ЛОР-справочник

Разборы клинических рекомендаций

81 рекомендаций Минздрава РФ · сборка от 28.10.2026 · каждый пункт сверен с текстом КР

Оглавление

Абсцесс, фурункул и карбункул носа 17
J34.0

1. Основные положения 18
2. Клиническая картина и классификация 18
3. Диагностика 21
4. Лечение 23
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 28
6. Источник и актуальность 30

Аллергический ринит 31
J30.1, J30.2, J30.3, J30.4

1. Основные положения 32
2. Клиническая картина и классификация 32
3. Диагностика 34
4. Лечение 37
5. Особенности лечения у детей, при беременности и лактации 42
6. Контроль лечения 43
7. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 44
8. Источник и актуальность 44

Анафилактический шок 46
T78.0, T78.2, T80.5, T88.6

1. Основные положения 47
2. Клиническая картина и классификация 47
3. Диагностика 49
4. Лечение 51
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 53
6. Источник и актуальность 54

Аномалии и деформации зубочелюстной системы и лицевого черепа 55
K07.0, K07.1, K07.4, Q18

1. Основные положения 56
2. Клиническая картина и классификация 56
3. Диагностика 57
4. Лечение 58
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации и выписке 61
6. Источник и актуальность 62

Болезнь Меньера 64
H81.0

1. Основные положения 65
2. Клиническая картина и классификация 65
3. Диагностика 67
4. Лечение 70
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 72
6. Источник и актуальность 72

Вирусные менингиты у детей 74
A87.0, A87.1, A87.2, A87.8, A87.9, B00.3, B01.0, B02.1, B05.1, B26.1, G02.0, G03.9

1. Основные положения 75
2. Клиническая картина и классификация 75
3. Диагностика 76
4. Лечение 78
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 79
6. Источник и актуальность 80

Воспалительные заболевания челюстей у детей 81
K10.2, M86

1. Основные положения 82
2. Клиническая картина и классификация 82
3. Диагностика 84
4. Лечение 86
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 88
6. Источник и актуальность 89

Врождённая цитомегаловирусная инфекция 90
P35.1

1. Основные положения 91
2. Клиническая картина и классификация 91
3. Диагностика 93
4. Лечение 96
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 97
6. Источник и актуальность 98

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей 100
K21, K21.0, K21.9

1. Основные положения 101
2. Клиническая картина и классификация 101
3. Диагностика 103
4. Лечение 108
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 112
6. Источник и актуальность 113

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин 114
J31.1, J35.1, J35.2, J35.3, J35.8

1. Основные положения 115
2. Клиническая картина и классификация 115

3. Диагностика 117
4. Лечение 119
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 122
6. Источник и актуальность 124

Головная боль напряжения **125**
G44, G44.2, G44.3, G44.4, G44.8, G90.8

1. Основные положения 126
2. Клиническая картина и классификация 126
3. Диагностика 127
4. Лечение 130
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 133
6. Источник и актуальность 134

Головная боль напряжения у детей **135**
G44, G44.2, G44.3, G44.8, G90.8

1. Основные положения 136
2. Клиническая картина и классификация 136
3. Диагностика 137
4. Лечение 140
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 143
6. Источник и актуальность 143

Грибковый отит **144**
B37.8, B44.8, B49, H60.8, H62.2, H66.3

1. Основные положения 145
2. Клиническая картина и классификация 145
3. Диагностика 147
4. Лечение 149
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 151
6. Источник и актуальность 151

Грипп у взрослых **152**
J09, J10, J11

1. Основные положения 153
2. Клиническая картина и классификация 153
3. Диагностика 155
4. Лечение 157
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 159
6. Источник и актуальность 160

Грипп у детей **162**
J09, J10, J11

1. Основные положения 163
2. Клиническая картина и классификация 163
3. Диагностика 165
4. Лечение 166

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 168
6. Источник и актуальность 169

Деформация перегородки носа 170
J34.2

1. Основные положения 171
2. Клиническая картина и классификация 171
3. Диагностика 172
4. Лечение 173
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 173
6. Источник и актуальность 174

Дистония 175
G24, G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9

1. Основные положения 176
2. Клиническая картина и классификация 176
3. Диагностика 177
4. Лечение 178
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 178
6. Источник и актуальность 178

Дифференцированный рак щитовидной железы 180
C73, D44.0

1. Основные положения 181
2. Клиническая картина и классификация 181
3. Диагностика 182
4. Лечение 184
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 185
6. Источник и актуальность 185

Доброкачественные образования головы и шеи 187
D10.0, D10.1, D10.2, D10.3, D11.0, D11.7, D11.9, D13.0, D14.0, D16.0, D17.0, D18.0, D18.1, D19.0, D21.0, D22.0, D23.0, D23.1, D23.2, D23.3, D23.4, D36.0, D36.7, D36.9

1. Основные положения 188
2. Клиническая картина и классификация 188
3. Диагностика 190
4. Лечение 192
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 194
6. Источник и актуальность 194

Доброкачественные остео- и хондрогенные опухоли носа и пазух 196
D14.0

1. Основные положения 197
2. Клиническая картина и классификация 197
3. Диагностика 198
4. Лечение 200
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 202
6. Источник и актуальность 203

Злокачественные новообразования губы 204
C00
1. Основные положения 205
2. Клиническая картина и классификация 205
3. Диагностика 206
4. Лечение 207
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 208
6. Источник и актуальность 208

Злокачественные новообразования полости рта 209
C02.0, C02.1, C02.2, C02.3, C02.8, C02.9, C03, C04, C05.0, C06
1. Основные положения 210
2. Клиническая картина и классификация 210
3. Диагностика 212
4. Лечение 213
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 215
6. Источник и актуальность 215

Злокачественные опухоли слюнных желёз 217
C06.9, C07, C08
1. Основные положения 218
2. Клиническая картина и классификация 218
3. Диагностика 220
4. Лечение 221
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 225
6. Источник и актуальность 226

Инородное тело в пищеварительном тракте 227
T18
1. Основные положения 228
2. Клиническая картина и классификация 228
3. Диагностика 230
4. Лечение 232
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 237
6. Источник и актуальность 238

Кисты челюстно-лицевой области и шеи 239
K04.8, K09, K11.6, L72.0, Q18.0, Q18.1, Q18.2, Q18.8
1. Основные положения 240
2. Клиническая картина и классификация 240
3. Диагностика 242
4. Лечение 245
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 249
6. Источник и актуальность 250

Коклюш у детей 251
A37

1. Основные положения 252
2. Клиническая картина и классификация 252
3. Диагностика 255
4. Лечение 257
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 260
6. Источник и актуальность 262

Корь **264**
B05.9
1. Основные положения 265
2. Клиническая картина и классификация 265
3. Диагностика 267
4. Лечение 268
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 268
6. Источник и актуальность 269

Краниальные мононейропатии у взрослых **271**
B02.2, G44.0, G50.0, G50.1, G50.8, G50.9, G51.0, G51.1, G51.2, G51.3, G51.4, G51.8, G51.9, G52.0, G52.1, G52.2, G52.3, G52.7, G52.8, G52.9, G53.0, G90.0
1. Основные положения 272
2. Клиническая картина и классификация 272
3. Диагностика 279
4. Лечение 289
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 300
6. Источник и актуальность 302

Крапивница **303**
L50, L50.0, L50.1, L50.2, L50.3, L50.4, L50.5, L50.6, L50.8, L50.9, T78.3
1. Основные положения 304
2. Клиническая картина и классификация 304
3. Диагностика 305
4. Лечение 307
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 308
6. Источник и актуальность 309

Круп, эпиглоттит, постинтубационный отёк гортани **310**
J05.0, J05.1, J38.4, J38.6
1. Основные положения 311
2. Клиническая картина и классификация 311
3. Диагностика 314
4. Лечение 317
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 321
6. Источник и актуальность 322

Мальформация кровеносных сосудов головы и шеи **323**
D10, D18, Q25.8, Q25.9, Q26.8, Q26.9, Q27, Q28.8, Q28.9
1. Основные положения 324
2. Клиническая картина и классификация 324

3. Диагностика 325
4. Лечение 327
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 329
6. Источник и актуальность 329

Мастоидит **331**
H70
1. Основные положения 332
2. Клиническая картина и классификация 332
3. Диагностика 335
4. Лечение 336
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 341
6. Источник и актуальность 341

Медуллярный рак щитовидной железы **343**
C73
1. Основные положения 344
2. Клиническая картина и классификация 344
3. Диагностика 345
4. Лечение 346
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 347
6. Источник и актуальность 347

Менингококковая инфекция у взрослых **348**
A39
1. Основные положения 349
2. Клиническая картина и классификация 349
3. Диагностика 351
4. Лечение 352
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 353
6. Источник и актуальность 354

Менингококковая инфекция у детей **355**
A39, Z22.3
1. Основные положения 356
2. Клиническая картина и классификация 356
3. Диагностика 357
4. Лечение 359
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 359
6. Источник и актуальность 360

Мигрень **361**
G43, G43.0, G43.1, G43.2, G43.3, G43.8, G43.9, G44.0, G44.1, G44.4
1. Основные положения 362
2. Клиническая картина и классификация 362
3. Диагностика 364
4. Лечение 367

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 372
6. Источник и актуальность 373

Мигрень у детей 374
G43.0, G43.1, G43.2, G43.3, G43.8, G43.9, G44.0, G44.1, G44.4

1. Основные положения 375
2. Клиническая картина и классификация 375
3. Диагностика 377
4. Лечение 379
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 382
6. Источник и актуальность 382

Множественные переломы мозгового и лицевого черепа 384
S02.0, S02.1, S02.4, S02.6, S02.7, S02.8, S02.9, S07

1. Основные положения 385
2. Клиническая картина и классификация 385
3. Диагностика 387
4. Лечение 389
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 393
6. Источник и актуальность 393

Наружные отиты 395
H60.0, H60.1, H60.2, H60.3, H60.4, H60.5, H60.8, H60.9, H61.0, H61.8, H61.9, H62.0, H62.1, H62.3, H62.4, H62.8

1. Основные положения 396
2. Клиническая картина и классификация 396
3. Диагностика 398
4. Лечение 399
5. Профилактика. Показания к госпитализации 401
6. Источник и актуальность 401

Наружный отит у детей 402
H60.0, H60.1, H60.2, H60.3, H60.5, H60.8, H60.9, H61.0, H61.8, H61.9, H62.0, H62.1, H62.2, H62.3, H62.4, H62.8

1. Основные положения 403
2. Клиническая картина и классификация 403
3. Диагностика 406
4. Лечение 409
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 412
6. Источник и актуальность 413

Наследственный ангиоотёк 414
D84.1

1. Основные положения 415
2. Клиническая картина и классификация 415
3. Диагностика 416
4. Лечение 418
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 419
6. Источник и актуальность 419

Нейросенсорная тугоухость у взрослых 420
H90.3, H90.4, H90.5, H91.1, H91.2, H91.8

1. Основные положения 421
2. Клиническая картина и классификация 421
3. Диагностика 424
4. Лечение и реабилитация 427
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 432
6. Источник и актуальность 433

Нейросенсорная тугоухость у детей 434
H90.3, H90.4, H90.5

1. Основные положения 435
2. Клиническая картина и классификация 435
3. Диагностика 437
4. Лечение 440
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 445
6. Источник и актуальность 447

Носовое кровотечение 448
R04.0

1. Основные положения 449
2. Клиническая картина и классификация 449
3. Диагностика 451
4. Лечение 453
5. Профилактика. Показания к госпитализации 455
6. Источник и актуальность 457

ОРВИ у детей 458
B34.0, B34.2, J00, J04.1, J06.0, J06.8, J06.9, J39.9

1. Основные положения 459
2. Клиническая картина и классификация 459
3. Диагностика 462
4. Лечение 465
5. Показания к госпитализации. Профилактика 470
6. Источник и актуальность 472

Одонтогенный остеомиелит челюсти 473
K10.2

1. Основные положения 474
2. Клиническая картина и классификация 474
3. Диагностика 475
4. Лечение 476
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 478
6. Источник и актуальность 478

Ожоги. Ожоги дыхательных путей 479
L55, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T27, T29, T30, T31, T32, T95

1. Основные положения 480
2. Клиническая картина и классификация 480
3. Диагностика 481
4. Лечение 483
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 484
6. Источник и актуальность 484

Опухоли слюнных желёз у детей 485
C06.9, C07, C08, D10.3, D11

1. Основные положения 486
2. Клиническая картина и классификация 486
3. Диагностика 488
4. Лечение 490
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 492
6. Источник и актуальность 493

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых 494
B34.0, B34.2, B34.9, B97.0, B97.4, J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J20, J21, J22

1. Основные положения 495
2. Клиническая картина и классификация 495
3. Диагностика 499
4. Лечение 503
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 510
6. Источник и актуальность 512

Острый ларингит 514
J04.0, J04.2

1. Основные положения 515
2. Клиническая картина и классификация 515
3. Диагностика 518
4. Лечение 520
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 524
6. Источник и актуальность 525

Острый синусит 526
J01

1. Основные положения 527
2. Клиническая картина и классификация 527
3. Диагностика 529
4. Лечение 532
5. Показания к госпитализации. Осложнения 537
6. Источник и актуальность 537

Острый тонзиллит и фарингит 538
J02, J02.0, J02.8, J02.9, J03, J03.0, J03.8, J03.9

1. Основные положения 539
2. Клиническая картина и классификация 539

3. Диагностика 540
4. Лечение 543
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации. Осложнения 547
6. Источник и актуальность 548

Отит средний острый 549
H65.0, H65.1, H66.0

1. Основные положения 550
2. Клиническая картина и классификация 550
3. Диагностика 552
4. Лечение 554
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 557
6. Источник и актуальность 558

Отосклероз 559
H80

1. Основные положения 560
2. Клиническая картина и классификация 561
3. Диагностика 562
4. Лечение 566
5. Медицинская реабилитация. Показания к госпитализации и выписке 570
6. Источник и актуальность 571

Паратонзиллярный абсцесс 573
J36, J39.0, J39.1

1. Основные положения 574
2. Клиническая картина и классификация 574
3. Диагностика 576
4. Лечение 578
5. Профилактика. Показания к госпитализации. Осложнения 580
6. Источник и актуальность 580

Парезы и параличи гортани 582
J38.0

1. Основные положения 583
2. Клиническая картина и классификация 583
3. Диагностика 586
4. Лечение 588
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 590
6. Источник и актуальность 590

Первичные иммунодефициты с недостаточностью синтеза антител 592
D80.0, D80.1, D80.2, D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D80.9, D83.0, D83.1, D83.2, D83.8, D83.9

1. Основные положения 593
2. Клиническая картина и классификация 593
3. Диагностика 595
4. Лечение 599

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 601
6. Источник и актуальность 602

Перелом верхней челюсти 603
S02.4

1. Основные положения 604
2. Клиническая картина и классификация 604
3. Диагностика 606
4. Лечение 607
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 609
6. Источник и актуальность 610

Полипозный риносинусит 611
J33.0, J33.1, J33.8, J33.9

1. Основные положения 612
2. Клиническая картина и классификация 612
3. Диагностика 614
4. Лечение 616
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 619
6. Источник и актуальность 620

Потеря слуха, вызванная шумом 622
H83.3, Z57.0

1. Основные положения 623
2. Клиническая картина и классификация 623
3. Диагностика 626
4. Лечение 631
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 633
6. Источник и актуальность 636

Простой герпес у взрослых 637
B00.1, B00.2, B00.3, B00.4, B00.7, B00.8, B00.9, B34.9, K12.1

1. Основные положения 638
2. Клиническая картина и классификация 638
3. Диагностика 640
4. Лечение 641
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 642
6. Источник и актуальность 643

РСВ-инфекция у детей 644
B97.4, J00, J02.8, J04.1, J04.2, J06.0, J20.5, J21.0

1. Основные положения 645
2. Клиническая картина и классификация 645
3. Диагностика 647
4. Лечение 650
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 651
6. Источник и актуальность 652

Рак гортани 653
C32, D38.0
1. Основные положения 654
2. Клиническая картина и классификация 654
3. Диагностика 656
4. Лечение 657
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 662
6. Источник и актуальность 663

Рак гортаноглотки 664
C12, C13
1. Основные положения 665
2. Клиническая картина и классификация 665
3. Диагностика 666
4. Лечение 667
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 672
6. Источник и актуальность 672

Рак носоглотки 674
C11
1. Основные положения 675
2. Клиническая картина и классификация 675
3. Диагностика 677
4. Лечение 678
5. Диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации и выписке 683
6. Источник и актуальность 684

Рак носоглотки у детей 685
C11
1. Основные положения 686
2. Клиническая картина и классификация 686
3. Диагностика 688
4. Лечение 691
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 693
6. Источник и актуальность 694

Рак полости носа и придаточных пазух 695
C30, C31
1. Основные положения 696
2. Клиническая картина и классификация 696
3. Диагностика 698
4. Лечение 699
5. Диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации и выписке 703
6. Источник и актуальность 704

Рак ротоглотки 706
C01, C02.4, C05.1, C05.2, C09, C10, D37.0

1. Основные положения 707
2. Клиническая картина и классификация 707
3. Диагностика 710
4. Лечение 712
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 720
6. Источник и актуальность 721

Рак щитовидной железы у детей 722
C73
1. Основные положения 723
2. Клиническая картина и классификация 723
3. Диагностика 725
4. Лечение 728
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 733
6. Источник и актуальность 734

Расщелина верхней губы и нёба 735
Q35, Q36, Q37
1. Основные положения 736
2. Клиническая картина и классификация 736
3. Диагностика 737
4. Лечение 739
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 741
6. Источник и актуальность 741

Саркоидоз 743
D86.0, D86.1, D86.2, D86.3, D86.8, D86.9
1. Основные положения 744
2. Клиническая картина и классификация 744
3. Диагностика 747
4. Лечение 750
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 753
6. Источник и актуальность 753

Сифилис 755
A50, A51, A52, A53
1. Основные положения 756
2. Клиническая картина и классификация 756
3. Диагностика 758
4. Лечение 759
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 760
6. Источник и актуальность 760

Сотрясение головного мозга 761
S06.0
1. Основные положения 762
2. Клиническая картина и классификация 762

3. Диагностика 763
4. Лечение 764
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 765
6. Источник и актуальность 765

Травма гортани **766**
R04.1, S10.0, S10.1, S11.0
1. Основные положения 767
2. Клиническая картина и классификация 767
3. Диагностика 770
4. Лечение 772
5. Медицинская реабилитация и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 777
6. Источник и актуальность 778

Травма носа **779**
S00.3, S01.2, S02.2
1. Основные положения 780
2. Клиническая картина и классификация 780
3. Диагностика 783
4. Лечение 785
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 791
6. Источник и актуальность 791

Травма уха **793**
S00.4, S01.3, S09.2
1. Основные положения 794
2. Клиническая картина и классификация 794
3. Диагностика 796
4. Лечение 798
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 801
6. Источник и актуальность 801

Химический ожог пищевода **802**
T28.5, T28.6, T28.7
1. Основные положения 803
2. Клиническая картина и классификация 803
3. Диагностика 807
4. Лечение 810
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 814
6. Источник и актуальность 815

Хронический ринит **816**
J30.0, J31.0, J34.3
1. Основные положения 817
2. Клиническая картина и классификация 817
3. Диагностика 820
4. Лечение 823

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 826
6. Источник и актуальность 826

Хронический синусит 827
J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J32.8, J32.9, J34.1

1. Основные положения 828
2. Клиническая картина и классификация 828
3. Диагностика 833
4. Лечение 835
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 839
6. Источник и актуальность 840

Хронический средний отит 842
H65.2, H65.3, H65.4, H66.1, H66.2, H66.3, H72.0, H90.0, H90.1, H90.2, H90.6, H90.7, H90.8

1. Основные положения 843
2. Клиническая картина и классификация 843
3. Диагностика 845
4. Лечение 849
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 854
6. Источник и актуальность 855

Хронический тонзиллит 856
J31.2, J35.0, J35.8, J35.9

1. Основные положения 857
2. Клиническая картина и классификация 857
3. Диагностика 859
4. Лечение 861
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 864
6. Источник и актуальность 864

Клинические рекомендации

Абсцесс, фурункул и карбункул носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J34.0** — Абсцесс, фурункул и карбункул носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/956_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Лечение по стадиям:
  1. стадия инфильтрации: консервативное лечение;
  2. абсцедирование и карбункул: вскрытие и дренирование гнойника без прекращения консервативной терапии.
- При фурункуле, карбункуле и абсцессе носа во всех случаях необходима системная антибактериальная терапия, направленная на санацию очага инфекции и профилактику осложнений.
- При каждом осмотре исключают признаки внутричерепных осложнений:
  1. синдром системной воспалительной реакции;
  2. неврологическая симптоматика;
  3. офтальмологическая симптоматика;
  4. тромбоз угловой вены и кавернозного синуса.
- Внутрь применяют амоксициллин + клавулановую кислоту (взрослым 875/125 мг 2 раза в сутки, 7 дней); для парентерального введения препаратом первой линии является цефазолин.
- Местно всем пациентам применяют антисептики и мази с антибиотиками (мупироцин, фузидовая кислота).
- При подозрении на тромбоз кавернозного синуса показана компьютерная томография (КТ) головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием; признаки тромбоза приведены во вкладке «Диагностика».
- Госпитализация:
  1. дети: во всех случаях, в круглосуточный оториноларингологический стационар;
  2. взрослые в стадии инфильтрации могут лечиться амбулаторно.
- Массаж области носа и выдавливание содержимого фурункула противопоказаны.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. фурункул носа: острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и сальной железы на кончике или крыльях носа, в преддверии носа или в области дна носа у верхней губы;
2. карбункул носа: гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов и сальных желёз с распространением вглубь и по поверхности, с обширными некрозами кожи и подкожной клетчатки;
3. абсцесс носа (абсцедирующий фурункул): скопление гноя при острой инфекции с деструкцией тканей в очаге, часто с перифокальным отёком.

2.2 Этиология

Ведущая роль в возникновении фурункула и карбункула носа принадлежит золотистому стафилококку; доказанным резервуаром инфекции и источником заражения служат его бессимптомные носители. Стрептококки, прежде всего бета-гемолитический стрептококк группы А, также могут вызывать пиодермии кожи и фурункул носа.

Факторы риска инфицирования волосяного фолликула

1. микротравмы кожи носа и преддверия носа;
2. загрязнение кожи техническими маслами и пылью при несоблюдении личной гигиены;
3. состояния, снижающие местный иммунитет кожи: переохлаждение, перегревание, стресс, нарушение секреторной функции кожи.

У детей предрасполагающим фактором чаще служат микротравмы кожи преддверия носа при «ковырянии» в носу и чрезмерном сморкании.

Фурункул носа нередко является проявлением фурункулёза, то есть образования множественных фурункулов на фоне вторичного иммунодефицита при эндокринных заболеваниях, прежде всего при сахарном диабете, а также при гиповитаминозе, нарушениях питания и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

2.3 Патогенез

Опасным треугольником называют среднюю зону лица, ограниченную линиями, которые соединяют назион с углами рта. Венозная кровь от неё оттекает к кавернозному синусу через угловые вены, вены орбиты и крыловидное венозное сплетение.

Вены этой системы лишены клапанов, поэтому кровь может оттекать в полость черепа. Инфекция с кожи лица, наружного носа, полости носа и околоносовых пазух гематогенно распространяется в глазницу, далее в кавернозный синус и на головной мозг.

Структуры, проходящие через кавернозный синус и прилежащие к нему

1. внутренняя сонная артерия;
2. III, IV и VI пары черепных нервов;
3. первая и вторая ветви тройничного нерва;
4. гипофиз и клиновидная пазуха (прилежат к стенкам синуса).

Эти анатомические особенности могут стать причиной грозных жизнеугрожающих внутричерепных осложнений.

При снижении сопротивляемости организма и высокой вирулентности возбудителя возможна генерализация процесса: стафилококки распространяются в окружающие ткани или проникают в кровоток с развитием сепсиса. В зоне инфильтрата развивается тромбоз мелких вен, и увеличение воспалительного очага повышает угрозу распространения тромбоза.

2.4 Классификация

Стадии

1. I стадия: инфильтрация;
2. II стадия: абсцедирование.

2.5 Клиническая картина

Жалобы

1. боль в области носа;
2. головная боль;
3. слабость, снижение работоспособности;
4. повышение температуры тела до субфебрильных значений.

В общем анализе крови возможны сдвиг лейкоцитарной формулы влево и повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Фурункул может локализоваться на кончике носа, в преддверии носа, вблизи перегородки носа или в области дна носа.

Стадия инфильтрации

1. постепенно нарастающая гиперемия кожи над фурункулом;
2. локальная боль, усиливающаяся при мимических движениях и жевании;
3. нарастающая инфильтрация мягких тканей;
4. вокруг первичного очага некротическая ткань, формируется стержень фурункула;
5. на внутренней поверхности входа в нос болезненный конусовидный инфильтрат.

При благополучном течении происходит отторжение некротического стержня с выделением небольшого количества гноя, инфильтрат уменьшается, болевой синдром регрессирует, температура тела нормализуется, общее состояние улучшается.

Стадия абсцедирования

1. зона некроза увеличивается;
2. кожа над инфильтратом истончается;
3. появляется флюктуация, формируется абсцесс.

Карбункул и абсцесс носа

1. тяжёлое общее состояние, фебрильная лихорадка;
2. ощущение распирания и выраженная пульсирующая боль;
3. несколько плотных инфильтратов, сливающихся в единый увеличивающийся очаг;
4. обширная полость с гнойно-некротическим содержимым;
5. несколько отверстий на коже, из которых выделяются гной и некротизированные кровянистые массы.

У детей заболевание протекает тяжелее вследствие выраженного интоксикационного синдрома (головная боль, слабость, вялость, лихорадка). Местные изменения могут развиваться стремительнее, а обширный отёк и гиперемия верхней губы или щёчной области могут маскировать фурункул под заболевание челюстно-лицевой области.

2.6 Анамнез

В анамнезе возможны указания на переохлаждение и косметические процедуры в области наружного носа и его преддверия.

3. Диагностика

Диагноз устанавливают по трём критериям.

Жалобы

1. выраженная боль в области очага, усиливающаяся при прикосновении;
2. головная боль, недомогание;
3. повышение температуры тела.

Данные осмотра

1. гиперемия, отёк и инфильтрация мягких тканей наружного носа, преддверия носа и носо-лицевой области;
2. резкая болезненность при пальпации.

Передняя риноскопия

1. в преддверии носа у волосяного фолликула гиперемия кожи, инфильтрат и гнойный стержень в центре.

3.1 Первичный осмотр

Показания

1. каждый пациент с подозрением на фурункул носа: первичный осмотр оториноларинголога, врача общей практики или педиатра.

Наружный осмотр

1. гиперемия, отёк и болезненность в области преддверия и кончика носа;
2. прикосновение к носу и риноскопия болезненны;
3. кожа преддверия может быть покрыта толстыми жёлтыми корками;
4. при выраженном воспалении отёк распространяется на щёчную область и верхнюю губу.

3.2 Передняя риноскопия

Основной метод инструментальной диагностики, выполняется всем пациентам: уточняет локализацию фурункула.

Диагностические признаки в динамике

1. начало: остиофолликулит преддверия носа, гиперемия и уплотнение в устье волосяного фолликула;
2. в течение **1–2 суток**: отёк, инфильтрация и гиперемия кожи входа в нос (стадия инфильтрации);
3. затем кожа истончается, ткани в очаге гнойно-некротически расплавляются с образованием детрита.

3.3 Признаки внутричерепных осложнений (оценивают при каждом осмотре)

При каждом осмотре необходимо оценивать наличие симптомов внутричерепных осложнений, которые объединяются в три синдрома: инфекционный, неврологический и офтальмологический.

Инфекционный синдром (синдром системной воспалительной реакции)

1. температура тела **38 °C и выше** или **36 °C и ниже**;
2. частота сердечных сокращений **90 в минуту и более**;
3. частота дыхания **более 20 в минуту**;
4. лейкоциты более 12 × 10^9/л или менее 4 × 10^9/л либо незрелых форм более 10%;
5. прокальцитонин в плазме **0,5 нг/мл и выше**.

Неврологический синдром

1. интенсивная головная боль;
2. тошнота и рвота, не связанные с приёмом пищи;
3. несистемное головокружение;
4. менингеальный синдром: светобоязнь, звукобоязнь, гиперестезия кожи, ригидность затылочных мышц; симптомы Кернига и Брудзинского, скуловой симптом Бехтерева, симптом Менделя;
5. при прогрессировании оглушение, психомоторное возбуждение, судорожный синдром.

Офтальмологический синдром

1. отёк век на стороне поражения;
2. хемоз;
3. экзофтальм;
4. болезненные тромбированные вены при пальпации век;
5. при офтальмоскопии признаки внутричерепной гипертензии.

Тромбоз угловой вены

1. резкая болезненность при пальпации;
2. интенсивная головная боль;
3. отёк лица на стороне поражения;
4. угловая вена пальпируется в виде плотного болезненного тяжа.

Тромбоз кавернозного синуса

1. на начальном этапе выраженный цианоз слизистой оболочки губ, кожи лба и носа;
2. нарастающий отёк верхней губы и щеки на стороне поражения с распространением на височную и лобную области, веки и противоположную половину лица;
3. нарушение функции глазодвигательного, блокового, отводящего и тройничного нервов вплоть до полного выпадения.

3.4 Компьютерная томография головного мозга с контрастированием

Показания

1. подозрение на тромбоз кавернозного синуса: КТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.

О возможном тромбозе кавернозного синуса свидетельствуют фебрильная лихорадка, головная боль, хемоз, экзофтальм и признаки поражения III, IV, V и VI пар черепных нервов.

3.5 Консультации специалистов

Показания

1. осложнённое течение: первичные консультации офтальмолога и невролога.

При распространении воспалительного процесса на область лица целесообразна консультация челюстно-лицевого хирурга.

Алгоритм ведения пациента (приложение Б) при внутричерепных осложнениях предусматривает консультации нейрохирурга, офтальмолога и челюстно-лицевого хирурга.

> Состав консультантов при осложнениях в разных разделах рекомендации не совпадает: в разделе 2.5 и в критериях качества указаны невролог и офтальмолог, в алгоритме (приложение Б) указаны нейрохирург, офтальмолог и челюстно-лицевой хирург.

3.6 Общий анализ крови

Выполняется всем пациентам на любой стадии для оценки общего состояния и выраженности воспаления.

3.7 Биохимический анализ крови

Показания

1. выявление сахарного диабета, нарушений углеводного обмена и других состояний, способствующих развитию фурункула и утяжеляющих его течение.

Оценка результатов

1. сахарный диабет неблагоприятно влияет на частоту развития, течение и прогноз фурункула;
2. повышен уровень глюкозы: направить к эндокринологу для коррекции гликемии, выявления сахарного диабета и назначения лечебного питания;
3. изменения билирубина, креатинина, мочевины, активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ): нарушение функции печени и почек.

3.8 Коагулограмма

Показания

1. осложнённое течение;
2. сопутствующие заболевания.

3.9 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого

Посев гнойного отделяемого на аэробную и факультативно-анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. абсцедирующий фурункул;
2. карбункул;
3. абсцесс носа.

Материал забирают из раны после вскрытия, без контакта с окружающими тканями, до начала антибактериальной терапии.

---

4. Лечение

1. метод лечения определяется стадией и характером проявлений, в том числе наличием карбункула или абсцесса;
2. при неосложнённом течении лечение преимущественно консервативное: местное и парентеральное;
3. лечение комплексное: элиминация возбудителя, купирование интоксикации, восстановление обмена веществ, повышение защитных сил организма.

По алгоритму ведения пациента (приложение Б):

1. стадия инфильтрации: консервативное лечение;
2. стадия абсцедирования: хирургическое лечение в сочетании с консервативным;
3. стадия разрешения: консультация физиотерапевта;
4. рецидив: консультации эндокринолога и аллерголога-иммунолога.

4.1 Стадия инфильтрации: консервативное лечение

Для подавления инфекции и воспаления у всех пациентов с фурункулом носа местно применяют антисептики.

1. в первые часы после появления инфильтрата: повторное смазывание пустулы 5% спиртовым раствором йода;
2. выраженное действие: четвертичные аммониевые соединения (бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний), препараты йода, хлоргексидин; допустимы у взрослых и детей;
3. повидон-йод разрешён детям **старше 28 дней**;
4. кратность обработки по выраженности воспаления, обрабатывают до разрешения инфекционного процесса;
5. в стадии инфильтрации кожу вокруг очага бережно обрабатывают 70% этанолом.

При фурункуле и карбункуле носа для санации очага местно используют мази с антибиотиками широкого спектра действия.

Мупироцин, мазь

1. взрослые: 2–3 раза в день, 5–7 дней;
2. дети с рождения: 2–3 раза в день, не более 10 дней.

Фузидовая кислота

1. взрослые: мазь или крем на кожу над фурункулом до 3–4 раз в день, 7–14 дней;
2. дети с рождения: крем 3–4 раза в день, 7–14 дней.

Диоксометилтетрагидропиримидин + хлорамфеникол, мазь: противомикробное и противовоспалительное действие

1. взрослые и дети с одного года: один раз в день до очищения раны от гнойно-некротических масс.

Для купирования воспаления и болевого синдрома при отсутствии противопоказаний рекомендуется противовоспалительная и обезболивающая терапия.

НПВП и другие анальгетики-антипиретики в монотерапии или в комбинации; выраженный эффект даёт сочетание НПВП с парацетамолом.

Метамизол натрия купирует болевой синдром у взрослых и детей, в том числе в послеоперационном периоде.

НПВП у детей

1. ибупрофен: с 3 месяцев;
2. кетопрофен: с 15 лет;
3. кетопрофен, гранулы для приготовления раствора внутрь: с 6 лет.

В амбулаторной практике от назначения метамизола натрия детям следует воздержаться; в стационаре препарат применяется только при отсутствии других анальгетиков, разрешённых к применению у детей, в связи с риском серьёзных нежелательных явлений.

Анальгетическая терапия у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	0,5–1 г внутривенно, инфузия в течение 15 минут	6 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 «мл» внутримышечно (так в таблице рекомендации; по смыслу 75 мг)	12 ч	150 мг	2 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Кеторолак	30 мг внутривенно или внутримышечно	8 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	не более 2 суток
Лорноксикам	8 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

> Разовая доза диклофенака в таблице 1 указана как «75 мл в/м»; исходя из смысла и суточного максимума 150 мг, речь идёт о 75 мг.

Анальгетическая терапия у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия в течение 15 минут: менее 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; более 50 кг — 1000 мг	4 ч	Менее 10 кг — менее 30 мг/кг; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 2 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 3 г; более 50 кг — 4 г	5–7 суток
Парацетамол внутрь	С 12 лет — 0,5–1 г; 6–12 лет — 240–480 мг; 1–6 лет — 120–240 мг; от 3 месяцев до года — 72–120 мг	6 ч	С 12 лет — 4 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 3 г; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 2 г; менее 10 кг — менее 30 мг/кг	С 12 лет — 3 суток, до 12 лет — 5–7 суток
Парацетамол в ректальных суппозиториях	10–14 лет — 500 мг; 5–9 лет — 250 мг; 1–4 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50–100 мг	4–6 ч	Менее 60 мг/кг	До 5 суток
Ибупрофен внутрь	Старше 6 лет — 200–400 мг; 4–6 лет — 150 мг; 1–3 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50 мг	8 ч	12–17 лет — 1 г; 6–12 лет — 800 мг; 4–6 лет — 450 мг; 1–3 года — 300 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 3–6 месяцев — 150 мг	4 суток
Ибупрофен в ректальных суппозиториях	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	8 ч (3–9 месяцев), 6 ч (9–24 месяца)	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	Не более 3 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Кетопрофен	С 15 лет — 100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	Не более 2 суток
Кетопрофен в гранулах для раствора внутрь	Старше 6 лет — 40 мг	8 ч	120 мг	Не более 2 суток
Метамизол натрия внутримышечно	13–14 лет — 0,8–1,8 мл (400–900 мг); 10–12 лет — 0,5–1,0 мл (250–500 мг); 7–9 лет — 0,4–1,0 мл (200–500 мг); 4–6 лет — 0,3–0,8 мл (150–400 мг); 1–3 года — 0,2–0,5 мл; 3–11 месяцев — 0,1–0,2 мл (50–100 мг)	8–12 ч	С 15 лет — 2 г; 8–14 лет — 900 мг; 4–7 лет — 600 мг; 2–3 года — 300 мг	1–5 суток

> В строке метамизола натрия таблицы 2 для детей 1–3 лет указано «0,2–0,5 мл (100–2500 мг)». При концентрации 500 мг в 1 мл, как и в соседних строках, 0,5 мл соответствуют 250 мг, следовательно, значение «2500» является опечаткой. Возраст «79 лет» в той же строке следует читать как 7–9 лет.

4.2 Системная антибактериальная терапия (все пациенты)

Всем пациентам с фурункулом, карбункулом и абсцессом носа для санации очага инфекции и предупреждения осложнений проводят системную антибактериальную терапию.

Препараты для приёма внутрь

Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь

1. взрослые и дети старше 12 лет или массой более 40 кг: 1000 мг (875/125) 2 раза в сутки, 7 дней;
2. дети от 3 месяцев до 12 лет массой менее 40 кг: суспензия (400 мг амоксициллина + 57 мг клавулановой кислоты в 5 мл), 20 мг/кг в сутки (кратность и длительность в КР не указаны);
3. новорождённые и дети до 3 месяцев: 30 мг/кг (по амоксициллину) 2 раза в день, 7–14 дней.

Цефдиторен

1. с 12 лет: 200 мг каждые 12 часов, 10 дней.

Тяжёлое или рецидивирующее течение, непереносимость бета-лактамных антибиотиков, пациенты с 18 лет:

1. левофлоксацин: 750 мг один раз в сутки, 7–14 дней;
2. моксифлоксацин: 400 мг один раз в сутки, 7 дней.

Препараты для парентерального введения

Цефазолин: препарат первой линии для парентерального введения

1. взрослые: 0,5 г внутривенно или внутримышечно 2 раза в день;
2. дети от месяца до 18 лет: 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения;
3. длительность: 7–10 дней.

Цефтриаксон, один раз в сутки

1. взрослые и дети старше 12 лет или массой более 50 кг: 1–2 г;
2. новорождённые до 14 дней: 20–50 мг/кг, не более 50 мг/кг;
3. дети от 15 дней до 12 лет: 20–80 мг/кг;
4. длительность: 7–10 дней.

Ампициллин + сульбактам внутримышечно или внутривенно (капельно 60–80 капель в минуту или струйно медленно в течение 3–5 минут)

1. взрослые: 3–12 г в сутки в 3–4 введения в зависимости от тяжести инфекции;
2. дети: 150 мг/кг в сутки в 3–4 введения;
3. недоношенные и дети первой недели жизни: 75 мг/кг в сутки в 2 введения;
4. длительность: 5–14 дней.

Амоксициллин + клавулановая кислота внутривенно

1. взрослые и дети старше 12 лет: 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки;
2. дети до 3 месяцев и массой менее 4 кг: 25/5 мг/кг каждые 8 часов, только медленной инфузией в течение 30–40 минут;
3. дети от 3 месяцев до 12 лет: 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов в зависимости от тяжести инфекции;
4. длительность: 5–14 дней.

Аллергия на бета-лактамные антибиотики

Клиндамицин

1. взрослые: парентерально 0,6–2,7 г в сутки в несколько введений;
2. дети 3–18 лет: 20–40 мг/кг в сутки в 3–4 равных приёма;
3. длительность: 7–10 дней.

Детям **младше 3 лет** противопоказан.

Парентеральные антибактериальные препараты

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Цефазолин	Взрослым 0,5 г; детям старше месяца 10–20 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям старше месяца 100 мг/кг	7–10 дней
Цефтриаксон	Взрослым 1–2 г; новорождённым до 14 дней 20–50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	1 раз в сутки	Взрослым 4 г, детям 2 г	7–10 дней
Ампициллин + сульбактам	Взрослым 1–2 г; детям старше месяца 50 мг/кг; новорождённым до 14 дней 75 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	Взрослым и детям старше месяца 3 раза, новорождённым 2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям 150 мг/кг	5–14 дней внутримышечно (или 5–7 дней внутривенно, затем внутримышечно до 14 дней)
Амоксициллин + клавулановая кислота	Взрослым и детям старше 12 лет 1 г внутривенно; до 12 лет 25 мг/кг внутривенно	Взрослым и детям старше 3 месяцев 3 раза, детям до 3 месяцев 2–3 раза в сутки	Взрослым и детям старше 12 лет 6 г, до 12 лет 50–75 мг/кг	5–14 дней

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Клиндамицин	Взрослым «0,2–0,9 мг» (так в таблице; внутримышечно не более 0,6 г, внутривенно не более 1,2 г на одно введение); детям 3–18 лет 5–10 мг/кг внутримышечно или внутривенно	3–4 раза в сутки	Взрослым 4,8 г, детям 40 мг/кг	7–10 дней

Данные раздела 3.1 и таблицы 3 не совпадают. Цефазолин детям: в тексте 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения, в таблице 10–20 мг/кг 2 раза в сутки. Ампициллин с сульбактамом: в тексте взрослым до 12 г в сутки, в таблице максимальная доза 6 г; новорождённым в тексте 75 мг/кг в сутки в 2 введения, в таблице 75 мг/кг на введение 2 раза в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 25 мг/кг каждые 6–8 часов (до 100 мг/кг в сутки), в таблице максимальная доза 50–75 мг/кг в сутки. Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице указана в миллиграммах («0,2–0,9 мг»), хотя, исходя из смысла и текста (0,6–2,7 г в сутки), речь идёт о граммах.

4.3 Стадия абсцедирования, карбункул, абсцесс: хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению:

1. стадия абсцедирования;
2. карбункул носа.

При осложнённом течении абсцесс или карбункул носа вскрывают, чтобы эвакуировать гной и обеспечить дренирование.

Вмешательство возможно как под местной анестезией, так и под общим обезболиванием. Забор материала из раны для бактериологического исследования обязателен.

4.4 Осложнённое течение: антикоагулянтная терапия

Осложнённое течение фурункула, карбункула или абсцесса носа во всех случаях требует профилактики тромбозов антикоагулянтами прямого или непрямого действия.

Доза подбирается под контролем показателей свёртывающей системы крови.

4.5 Стадия разрешения

В стадии разрешения для ускорения выздоровления показана консультация физиотерапевта.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Рецидивирующее течение

При рецидивирующих фурункулах носа рекомендована консультация эндокринолога (у детей детского эндокринолога) для выявления причины рецидивов.

В ряде случаев целесообразна также консультация аллерголога-иммунолога.

Для профилактики рецидивов при рецидивирующем течении фурункула носа применяют бактериофаги.

Местное применение бактериофагов в комплексном лечении оправдано при устойчивости выделенных штаммов к антибиотикам, при наличии в анамнезе более двух курсов антибактериальной терапии, при непереносимости антибиотиков и при рецидивирующем течении.

5.2 Профилактика

Основа профилактики

1. личная гигиена: мытьё рук до и после еды, после туалета, поездок в транспорте и посещения общественных мест;
2. гигиена труда, средства защиты при работе в условиях запылённости и загрязнения;
3. запрет прикосновений к коже лица грязными руками, массажа болезненных участков, выдавливания фурункула и самолечения;
4. при сахарном диабете и других заболеваниях соблюдение диеты и своевременный приём препаратов;
5. обучение гигиеническим навыкам в семье, детском саду и школе.

Пациенту разъясняют

1. осторожность при косметическом уходе за лицом, включая чистку лица и бритьё;
2. при гнойничке на коже носа или верхней губы массаж и выдавливание категорически противопоказаны;
3. при отёке или гиперемии в области фурункула обращаться в оториноларингологический стационар.

Родителям

1. контролировать чистоту рук ребёнка;
2. обучать правильному туалету носа;
3. не допускать ковыряния в носу.

5.3 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. дети: установленный диагноз абсцесса, фурункула или карбункула носа (круглосуточный оториноларингологический стационар).

Взрослые в стадии инфильтрации могут лечиться у оториноларинголога амбулаторно. В большинстве случаев пациентов ведёт оториноларинголог в хирургическом стационаре.

Вслед за разрешением амбулаторного лечения КР отдельно упоминает пациентов в стадии инфильтрации с сопутствующими (коморбидными) заболеваниями и пациентов с рецидивирующими фурункулами; фраза не закончена, тактика не указана, по контексту такие пациенты к амбулаторному лечению не отнесены.

> В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими заболеваниями и рецидивирующими фурункулами не закончена и тактика их ведения не указана; по контексту, по-видимому, подразумевается госпитализация. Кроме того, в информации для пациента (приложение В) при отёке или гиперемии в области фурункула всем пациентам рекомендуется обращаться в оториноларингологический стационар, хотя гиперемия и отёк отмечаются уже в стадии инфильтрации, при которой взрослые, согласно разделу 6, могут получать лечение амбулаторно.

Показания к выписке

1. разрешении абсцесса, фурункула или карбункула;
2. отсутствии осложнений;
3. удовлетворительном общем состоянии;
4. нормализации температуры тела.

При неосложнённом течении прогноз благоприятный. У пациентов с первичным или вторичным иммунодефицитом и с сахарным диабетом следует ожидать более тяжёлого течения и высокого риска осложнений.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Абсцесс. Фурункул носа. Карбункул носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	956_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 разовая доза диклофенака указана как «75 мл».
- В таблице 2 для метамизола натрия у детей 1–3 лет указано «100–2500 мг» (объёму 0,2–0,5 мл соответствуют 100–250 мг), а возраст «79 лет» означает 7–9 лет.
- Дозы антибактериальных препаратов в тексте раздела 3.1 и в таблице 3 не совпадают: доза цефазолина у детей, максимальная доза ампициллина с сульбактамом у взрослых и его доза у новорождённых, суточная доза амоксициллина с клавулановой кислотой у детей.
- Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице 3 указана как «0,2–0,9 мг» вместо граммов; в тексте фраза «противопоказан детям в возрасте старше до 3-х лет» искажена (по контексту имеется в виду возраст младше 3 лет).
- Состав консультантов при внутричерепных осложнениях в разделе 2.5 и в критериях качества (невролог, офтальмолог) не совпадает с алгоритмом в приложении Б (нейрохирург, офтальмолог, челюстно-лицевой хирург).
- В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими заболеваниями и рецидивирующими фурункулами не закончена; рекомендация из приложения В обращаться в стационар при любом отёке или гиперемии расходится с возможностью амбулаторного лечения взрослых в стадии инфильтрации.
- Показания к хирургическому лечению сформулированы по-разному: в разделе 3.2 указаны абсцедирование и карбункул, в тезисе-рекомендации указано осложнённое течение, в критериях качества указана стадия абсцедирования.

Клинические рекомендации

Аллергический ринит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J30.1** — Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений **J30.2** — Другие сезонные аллергические риниты **J30.3** — Другие аллергические риниты **J30.4** — Аллергический ринит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 11.07.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/261_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз аллергического ринита:

  Обязательные критерии

  1. **не менее двух** из четырёх симптомов, беспокоящих ежедневно **не менее часа**: заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу;
  2. связь симптомов с аллергеном;
  3. положительные результаты аллергологического обследования.
- Лечение ступенчатое:
  1. первая ступень: один препарат: антигистаминный внутрь или интраназально, кромоглициевая кислота или монтелукаст;
  2. вторая ступень: один препарат, предпочтительно интраназальный глюкокортикостероид;
  3. третья ступень: интраназальный глюкокортикостероид и один или несколько препаратов первой ступени;
  4. четвёртая ступень: омализумаб, решение о котором принимает только специалист.
- Интраназальные глюкокортикостероиды превосходят по эффективности антигистаминные препараты для приёма внутрь и кромоглициевую кислоту, особенно при выраженной заложенности носа.
- Сосудосуживающие препараты допустимы только при обострении с выраженной заложенностью носа и только коротким курсом, **3–7 дней**.
- Контроль симптомов оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» при первичном обращении и **через 2–4 недели** лечения.
- Лечение, как правило, амбулаторное.

  Показания к госпитализации

  1. крайне тяжёлое или осложнённое течение;
  2. у детей тяжёлое обострение с выраженной заложенностью носа;
  3. плановое проведение ускоренного курса АСИТ.
- Хирургическое лечение показано только при сопутствующей патологии. Плановые операции в сезон пыления причинно-значимых аллергенов не выполняют.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Аллергический ринит является IgE-опосредованным воспалительным заболеванием слизистой оболочки носа, развивающимся под действием аллергенов. Для него характерны **не менее двух** симптомов, проявляющихся ежедневно **в течение часа и более**:

1. заложенность носа;
2. ринорея;
3. чихание;
4. зуд в полости носа.

2.2 Классификация

По этиологическому фактору

1. сезонный;
2. круглогодичный (бытовой);
3. профессиональный.

По течению

1. интермиттирующий: симптомы беспокоят **менее 4 дней в неделю** или **менее 4 недель в году**;
2. персистирующий: симптомы сохраняются **более 4 дней в неделю** и **более 4 недель в году**.

По тяжести

1. лёгкое течение: симптомы не нарушают сон и повседневную активность;
2. среднетяжёлое течение: симптомы препятствуют работе, учёбе, занятиям спортом и нарушают сон;
3. тяжёлое течение: без лечения пациент не может нормально работать, учиться и спать.

Кроме того, выделяют периоды обострения и ремиссии.

В формулировке диагноза указываются аллергены, к которым выявлена повышенная чувствительность.

Отдельной формой является локальный аллергический ринит. Для него характерны типичные симптомы с чёткой связью с аллергеном при отрицательных результатах кожных проб и исследования специфических IgE в крови. Определение специфических IgE в носовом секрете в России не проводится, назальные провокационные тесты положительны.

2.3 Жалобы и анамнез

Жалобы

1. заложенность носа с дыханием через рот, сопением, храпом и изменением голоса;
2. водянистые выделения из носа;
3. чихание, нередко приступообразное, чаще в утренние часы;
4. зуд, реже жжение в носу, в ряде случаев зуд нёба и глотки;
5. на поздних стадиях снижение обоняния.

Характерен «аллергический салют» (потирание кончика носа ладонью), вследствие которого формируется поперечная носовая складка.

У каждого пациента с подозрением на аллергический ринит подробно собирают жалобы и анамнез.

Ведущие симптомы

1. круглогодичная форма: заложенность носа со слизистыми выделениями;
2. сезонная форма: приступы чихания, зуд и ринорея.

Уточняют

1. связь симптомов с аллергеном;
2. аллергические заболевания у пациента и его кровных родственников.

Обильные выделения и нарушение проходимости слуховых труб могут сопровождаться раздражением и отёком кожи над верхней губой и в области крыльев носа, носовыми кровотечениями после сморкания, болью в горле и покашливанием, болью и треском в ушах при глотании, снижением слуха.

При сезонном рините часто встречается оральный аллергический синдром, представляющий собой перекрёстную непереносимость свежих фруктов, овощей, орехов и семян. Его проявления варьируют от зуда в полости рта до анафилаксии.

2.4 Физикальное обследование

Обследование всех пациентов включает осмотр верхних дыхательных путей, общий осмотр и аускультацию для выявления бронхиальной астмы, конъюнктивита и атопического дерматита.

Характерные признаки

1. затруднённое носовое дыхание, приоткрытый рот;
2. тёмные круги под глазами;
3. мацерация кожи над верхней губой;
4. отёчность лица.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Обязательные критерии

1. характерные жалобы: **не менее двух** симптомов из четырёх, ежедневно **не менее часа**;
2. данные анамнеза о связи с аллергеном или о других аллергических заболеваниях;
3. положительные результаты аллергологического обследования.

Задачи оториноларинголога

1. риноскопия и эндоскопическое исследование;
2. дифференциальная диагностика;
3. выявление осложнений и анатомических нарушений;
4. определение показаний к хирургическому лечению.

Задачи аллерголога-иммунолога

1. кожные и провокационные тесты и оценка их результатов;
2. исключение бронхиальной астмы;
3. решение вопроса об аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

3.2 Передняя риноскопия

Выполняется всем пациентам.

Диагностические признаки

1. отёк носовых раковин;
2. обильный водянистый секрет;
3. слизистая оболочка ярко-красная в период обострения сезонного ринита;
4. слизистая оболочка цианотичная или серая при круглогодичном рините, в ряде случаев пятнистая («мраморная», симптом Воячека);
5. полипы.

3.3 Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки и околоносовых пазух

Показания

1. неэффективность стандартной терапии;
2. осложнённое течение ринита.

Проба с сосудосуживающим средством позволяет оценить обратимость назальной обструкции.

3.4 Кожные пробы

При отсутствии противопоказаний проводят prick-тесты или скарификационные пробы.

Показания

1. подтверждение аллергической природы ринита;
2. выявление причинно-значимых аллергенов;
3. решение вопроса об АСИТ.

Пробы проводят в аллергологическом кабинете.

На результат влияют

1. возраст **младше 5 и старше 60 лет**;
2. приём системных глюкокортикоидов, антигистаминных и психотропных препаратов;
3. дермографизм: ложноположительный результат;
4. недавно перенесённая острая аллергическая реакция: ложноотрицательный результат.

Накануне и в день постановки теста антигистаминные препараты системного действия не принимают.

Пробы не проводят

1. при выраженном обострении заболевания, например в сезон пыления причинных растений;
2. при повреждении кожи обоих предплечий и спины;
3. при невозможности отменить антигистаминные препараты системного действия;
4. во время беременности и грудного вскармливания.

3.5 Специфические IgE в сыворотке крови

Показания

1. кожные пробы противопоказаны или невозможны;
2. результат кожных проб сомнителен;
3. результат кожных проб расходится с данными анамнеза.

Диагностические признаки

При использовании метода ImmunoCAP результат считается положительным при значении **более 0,70 kU/l**.

Молекулярная (компонентная) диагностика всем пациентам не показана.

Показания

1. расхождение данных анамнеза и результатов кожных проб и специфических IgE;
2. неэффективность АСИТ;
3. назначение АСИТ рекомбинантными аллергенами.

При подозрении на появление новой клинически значимой сенсибилизации исследование можно повторить в течение года.

Назальный провокационный тест с аллергенами выполняется только взрослым и только аллергологом-иммунологом в аллергологическом кабинете или стационаре.

Показания

1. расхождение данных анамнеза и результатов других методов диагностики;
2. множественная сенсибилизация, когда для АСИТ нужно выбрать клинически значимый аллерген.

3.6 Общий IgE

Для диагностики аллергического ринита исследование общего IgE нецелесообразно, поскольку не несёт необходимой диагностической информации.

Показания

1. только перед назначением омализумаба (**с 12 лет**, при тяжёлом течении): по уровню общего IgE рассчитывают дозу препарата.

3.7 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. выраженные симптомы в период обострения;
2. подготовка к АСИТ.

Диагностические признаки

1. повышение содержания эозинофилов;
2. лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево служит поводом для поиска инфекции, прежде всего острого риносинусита.

3.8 Цитологическое исследование смывов из полости носа

Показания

1. выраженные симптомы в период обострения.

Диагностические признаки

1. эозинофилия носового секрета **10% и более**.

3.9 Рентгенография околоносовых пазух

Показания

1. симптомы риносинусита: гнойные выделения, боль в проекции пазух, головная боль, повышение температуры тела;
2. лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево.

3.10 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания

1. неэффективность лечения;
2. выраженная и длительная назальная обструкция;
3. стойкая аносмия;
4. отрицательные результаты аллергологического обследования, прежде всего при подозрении на полипозный риносинусит.

3.11 Спирометрия с бронхолитиком

Показания

1. кашель, свистящее дыхание, одышка;
2. подготовка к АСИТ: выявление скрытого бронхоспазма.

Снижение ОФВ1 **менее 70%** от должных величин относится к противопоказаниям к АСИТ.

3.12 Электрокардиография

Показания

1. подготовка к инъекционной АСИТ.

3.13 Дифференциальная диагностика

Заболевания для дифференциальной диагностики

1. инфекционный ринит;
2. аномалии внутриносовых структур;
3. аденоиды у детей;
4. полипозный риносинусит;
5. эозинофильный ринит;
6. лекарственный ринит: на фоне приёма нестероидных противовоспалительных препаратов, альфа- и бета-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, резерпина, длительного применения деконгестантов;
7. гормональный ринит: беременность, пубертатный период, менструальный цикл, приём контрацептивов, акромегалия, гипотиреоз;
8. профессиональный ринит;
9. атрофический ринит пожилых;
10. пищевой и алкогольный ринит;
11. идиопатический ринит;
12. первичная цилиарная дискинезия и муковисцидоз.

---

4. Лечение

Целью лечения является полный контроль симптомов. При продолжающемся контакте с аллергеном, табачным дымом или другими раздражителями достижимо лишь уменьшение выраженности симптомов.

4.1 Ступенчатая терапия

На любой ступени

1. исключение контакта с аллергеном;
2. хирургическое лечение сопутствующей патологии при наличии показаний;
3. рассмотрение вопроса об АСИТ.

Первая ступень: один из препаратов

1. антигистаминный препарат без седативного эффекта внутрь;
2. антигистаминный препарат интраназально;
3. кромоглициевая кислота интраназально;
4. монтелукаст.

Вторая ступень: один из препаратов

1. интраназальный глюкокортикостероид (предпочтительно);
2. антигистаминный препарат внутрь или интраназально;
3. монтелукаст.

Третья ступень: интраназальный глюкокортикостероид в сочетании с одним или несколькими препаратами

1. антигистаминный препарат внутрь;
2. антигистаминный препарат интраназально;
3. монтелукаст.

Четвёртая ступень

Омализумаб при тяжёлом течении, **с 12 лет**. Назначается только специалистом.

Препараты скорой помощи на любой ступени: сосудосуживающие препараты коротким курсом или глюкокортикоиды внутрь.

> Перед переходом на ступень выше следует повторно оценить правильность диагноза, приверженность лечению, наличие сопутствующих заболеваний и анатомических аномалий.

4.2 Системные антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты без седативного эффекта рекомендованы всем пациентам: они уменьшают зуд, чихание, ринорею и заложенность носа. Цетиризин в высоких дозах чаще других препаратов вызывает сонливость.

Назначение седативных антигистаминных препаратов первого поколения не рекомендуется, поскольку они вызывают сонливость, нарушают сон и могут приводить к развитию апноэ во сне.

Препарат	Доза
Дезлоратадин	1. взрослые и дети с 12 лет: 5 мг 1 раз в сутки; 2. дети 6–11 лет: 2,5 мг 1 раз в сутки; 3. дети 1–5 лет: 1,25 мг 1 раз в сутки; 4. дети 6–12 месяцев: 1 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 5 мг 1 раз в сутки; 2. дети 2–6 лет: 1,25 мг 2 раза в сутки.
Лоратадин	1. взрослые и дети старше 12 лет: 10 мг 1 раз в сутки; 2. дети 2–12 лет с массой тела до 30 кг: 5 мг 1 раз в сутки; 3. дети 2–12 лет с массой тела более 30 кг: 10 мг 1 раз в сутки.
Фексофенадин	1. взрослые и дети старше 12 лет: 120 мг 1 раз в сутки; 2. дети 6–11 лет: 30 мг 2 раза в сутки.
Цетиризин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 5–10 мг 1 раз в сутки; 2. дети 2–6 лет: 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз в сутки; 3. дети 1–2 лет: 2,5 мг 2 раза в сутки; 4. дети 6–12 месяцев: 2,5 мг 1 раз в сутки.
Эбастин	1. взрослые и дети старше 12 лет: 10–20 мг 1 раз в сутки; 2. лекарственная форма: имеется форма для рассасывания под языком.
Рупатадин	1. взрослые и дети старше 12 лет: 10 мг 1 раз в сутки.
Биластин	1. взрослые и дети старше 12 лет: 20 мг 1 раз в сутки.

4.3 Интраназальные глюкокортикостероиды

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение, особенно при выраженной заложенности носа.

По эффективности превосходят антигистаминные препараты для приёма внутрь и кромоглициевую кислоту, уменьшают и глазные симптомы.

Нежелательные явления

1. сухость слизистой оболочки;
2. носовые кровотечения;
3. редко перфорация носовой перегородки.

Пациента обучают правильной технике введения спрея.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Мометазон	1. взрослые и дети старше 12 лет: 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости до 4 доз; 2. поддерживающая терапия: 1 доза 1 раз в сутки; 3. дети 2–12 лет: 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Флутиказона фуроат	1. взрослые и дети старше 12 лет: 2 дозы (55 мкг) 1 раз в сутки; 2. поддерживающая терапия: 1 доза 1 раз в сутки; 3. дети 2–12 лет: 1 доза (27,5 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости 2 дозы.
Флутиказона пропионат	1. взрослые и дети старше 12 лет: 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки; 2. поддерживающая терапия: 1 доза 1 раз в сутки; 3. дети 4–12 лет: 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Будесонид	1. взрослые и дети старше 6 лет: 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки; 2. поддерживающая терапия: 200 мкг в сутки; 3. длительность: не более 3 месяцев.
Беклометазон	1. взрослые и дети старше 6 лет: 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки (максимальная доза); 2. поддерживающая терапия: 1 доза 2 раза в сутки.

4.4 Интраназальные антигистаминные и комбинированные препараты

Интраназальные антигистаминные препараты быстро, **в течение 30 минут**, уменьшают выраженность симптомов. Их применяют в монотерапии или в сочетании с другими препаратами; возможна сухость слизистой оболочки носа.

При необходимости одновременного интраназального применения антигистаминного препарата и глюкокортикостероида целесообразно назначение одного комбинированного спрея.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 1 доза (0,14 мг) 2 раза в сутки; 2. с 12 лет: при необходимости 2 дозы; 3. длительность: не более 6 месяцев.
Левокабастин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 2 дозы 2 раза в сутки, при выраженных симптомах 3–4 раза; 2. длительность: при отсутствии эффекта в течение 3 дней препарат отменяется.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин и флутиказон	1. взрослые и дети старше 12 лет: 1 доза (137 мкг азеластина и 50 мкг флутиказона) 2 раза в сутки.
Азеластин и мометазон	1. взрослые с 18 лет: 1 доза (140 мкг азеластина и 50 мкг мометазона) 2 раза в сутки; 2. длительность: 2 недели.
Мометазон и олопатадин	1. взрослые и дети старше 12 лет: 2 дозы 2 раза в сутки (в КР указано 50 мкг мометазона и 1200 мкг олопатадина); 2. дети 6–11 лет, только при сезонном рините: 1 доза (25 и 600 мкг) 2 раза в сутки.

4.5 Монелукаст и кромоглициевая кислота

Монелукаст может назначаться при любой степени тяжести, в монотерапии или в сочетании с другими препаратами, однако по эффективности он уступает интраназальным глюкокортикостероидам.

При сопутствующей бронхиальной астме монелукаст позволяет контролировать оба заболевания. Курс лечения **от 1 до 3 месяцев и более**; согласно инструкции, ограничений по длительности применения нет.

При необходимости назначения и антигистаминного препарата внутрь, и монелукаста возможно применение комбинированной таблетки левоцетиризина с монелукастом.

Кромоглициевую кислоту интраназально используют при лёгком течении. Препарат безопасен, однако по эффективности уступает антигистаминным препаратам, монелукасту и интраназальным глюкокортикостероидам.

Препарат	Доза
Монелукаст	1. взрослые и дети старше 15 лет: 10 мг 1 раз в сутки; 2. дети 6–15 лет: 5 мг 1 раз в сутки; 3. дети 2–6 лет: 4 мг (жевательная таблетка) 1 раз в сутки.
Левоцетиризин и монелукаст	1. взрослые и дети старше 15 лет: 1 таблетка (5 мг и 10 мг) 1 раз в сутки.
Кромоглициевая кислота, спрей	1. взрослые и дети старше 5 лет: 1 доза в каждый носовой ход 4 раза в сутки, при необходимости до 6 раз; 2. после достижения эффекта: возможно применение только при контакте с аллергеном; 3. длительность: 4 недели.

4.6 Сосудосуживающие препараты

При обострении с выраженной заложенностью носа сосудосуживающие препараты применяют коротким курсом, **3–7 дней**.

Длительное применение не рекомендуется: **после 10 дней** развиваются привыкание, отёк слизистой оболочки и медикаментозный ринит.

При необходимости интраназального применения и антигистаминного, и сосудосуживающего препарата возможно назначение комбинации диметиндена с фенилэфрином, не более 7 дней.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Оксиметазолин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 1–2 дозы 0,05% раствора 2–3 раза в сутки; 2. дети 1–6 лет: 1–2 капли 0,025% раствора 2–3 раза в сутки; 3. дети от 5 недель до года: 1–2 капли 0,01% раствора 2–3 раза в сутки; 4. дети до 4 недель: 1 капля 0,01% раствора 2–3 раза в сутки; 5. длительность: 3–4 дня.
Ксилометазолин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 1 доза 0,1% раствора 1–3 раза в сутки; 2. дети 2–6 лет: 1 доза 0,05% раствора 1–2 раза в сутки; 3. длительность: не более 5–7 дней.
Диметинден и фенилэфрин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 1–2 дозы спрея или 3–4 капли 3–4 раза в сутки; 2. дети 1–6 лет: только капли, по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.

4.7 Тяжёлое течение

При тяжёлом обострении или неэффективности третьей ступени возможно назначение короткого курса глюкокортикоидов внутрь.

Глюкокортикоиды системного действия: условия применения

1. терапия четвёртой линии или лечение тяжёлого обострения;
2. доза преднизолона, метилпреднизолона или дексаметазона подбирается индивидуально;
3. преднизолон в таблетках противопоказан детям **до 3 лет**.

Введение растворов и депо-форм глюкокортикоидов в носовые раковины недопустимо: риск тяжёлых осложнений вплоть до слепоты.

Назначение депо-форм глюкокортикоидов не рекомендуется в связи с быстрым развитием побочных эффектов, вплоть до надпочечниковой недостаточности.

Назначение омализумаба рассматривается **с 12 лет** при тяжёлом персистирующем течении или тяжёлом обострении в случае неэффективности третьей ступени.

Решение о назначении таргетной терапии принимает врачебный консилиум.
Препарат вводится подкожно каждые 2 или 4 недели в дозе от 75 до 600 мг в соответствии с таблицей дозирования. При сезонном рините у пациентов с тяжёлым течением, которые своевременно не прошли АСИТ, введение начинается не менее чем за неделю до начала пыления и продолжается до его окончания.
Эффект омализумаба развивается в течение 3–7 дней; при коротком сезоне пыления (1 месяц) полного контроля симптомов можно достичь 1–2 инъекциями.

4.8 Немедикаментозное лечение

Всем пациентам рекомендуется по возможности избегать контакта с аллергеном. Даже частичное ограничение контакта облегчает течение заболевания и снижает потребность в лекарственных препаратах.

Рекомендуется применение изотонических солевых растворов для носа, в том числе на основе морской воды.

Перед введением интраназального глюкокортикостероида полость носа целесообразно промыть: это улучшает контакт препарата со слизистой оболочкой и снижает частоту сухости и носовых кровотечений.

4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия

Проведение АСИТ рассматривается у всех пациентов в период ремиссии, в том числе медикаментозной. Метод уменьшает выраженность симптомов и потребность в лекарственных препаратах, предупреждает развитие бронхиальной астмы и расширение спектра аллергенов.

Показания, противопоказания и выбор аллергена определяются аллергологом-иммунологом, которым и назначается АСИТ.

4.10 Хирургическое лечение

К хирургическому лечению прибегают только при сопутствующей патологии; показания определяются оториноларингологом по данным эндоскопического и рентгенологического исследования. Плановые операции в сезон пыления причинно-значимых аллергенов не выполняют.

В сезон цветения растений, к пыльце которых есть аллергия, не рекомендуется и профилактическая вакцинация. Её проводят до начала сезона цветения или откладывают до его завершения.

4.11 Нетрадиционные методы

Гомеопатия, фитотерапия, гипноз, техники релаксации, ионизаторы воздуха и физиотерапия не рекомендуются в связи с отсутствием доказательств их эффективности.

Иглоукалывание может рассматриваться в составе комплексной терапии.

---

5. Особенности лечения у детей, при беременности и лактации

5.1 Возрастные ограничения

Интраназальные глюкокортикостероиды у детей

1. мометазон, флутиказона фуроат: **с 2 лет**;
2. флутиказона пропионат: **с 4 лет**;
3. беклометазон, будесонид: **с 6 лет**.

Антигистаминные препараты у детей

1. цетиризин, дезлоратадин: **с 6 месяцев**;
2. лоратадин: **с 2 лет**;
3. первого поколения (хлоропирамин, диметинден): **с 1 месяца**.

По достижении ребёнком соответствующего возраста предпочтение отдают препаратам без седативного эффекта.

Монтелукаст у детей

1. 4 мг: **с 2 лет**;
2. 5 мг: **с 6 лет**.

У детей особое внимание уделяют элиминационным мероприятиям и промыванию полости носа изотоническими солевыми растворами или применению барьерных средств на основе микрокристаллической целлюлозы, сводя медикаментозную нагрузку к минимуму.

У детей интраназальные глюкокортикостероиды уменьшают не только назальную обструкцию и другие симптомы ринита, но и гипертрофию аденоидов, а следовательно, и потребность в хирургическом лечении.

Кромоглициевая кислота безопасна и эффективна в отношении зуда в носу, чихания и ринореи, однако её применение ограничено высокой кратностью введения, меньшей эффективностью по сравнению с интраназальными глюкокортикостероидами и отсутствием эффекта в отношении заложенности носа.

Согласно инструкциям к препаратам, АСИТ возможна **с 5 лет**.

Детям интраназальные глюкокортикостероиды применяют в минимальной эффективной дозе; при длительном применении необходим контроль роста.

Предпочтительно ограничить применение препаратов с высокой биодоступностью: будесонида (30–40%) и беклометазона (40–50%). Биодоступность дексаметазона превышает 80%, что следует учитывать, поскольку он входит в состав многих комбинированных капель.

5.2 Беременность и лактация

У беременных необходимо учитывать возможность ринита беременных, который характеризуется заложенностью носа без признаков инфекции и аллергии и полностью регрессирует **в течение 2 недель** после родов. Выявленная сенсибилизация свидетельствует в пользу аллергического ринита.

Кожные пробы во время беременности и лактации не выполняют; для аллергологического обследования исследуется уровень специфических IgE в сыворотке крови.

Предпочтение отдаётся элиминационным мероприятиям и промыванию полости носа. К лекарственной терапии переходят при их недостаточной эффективности с учётом рисков для матери и ребёнка.

Для лоратадина, цетиризина и будесонида доказательства риска для человека отсутствуют (категория B по классификации Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, FDA).

В первом триместре назначения лекарственных препаратов по возможности следует избегать, за исключением случаев жизненной необходимости.

В период лактации предпочтительно ограничиться местными средствами с минимальной системной биодоступностью. Все системные препараты проникают в грудное молоко, поэтому при необходимости их назначения следует рассмотреть вопрос о прекращении грудного вскармливания.

---

6. Контроль лечения

Контроль симптомов оценивается по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» при первичном обращении и **через 2–4 недели** лечения. Методика оценки приведена ниже.

Визуальная аналоговая шкала представляет собой линию длиной 10 см, на которой пациент отмечает выраженность беспокоящих его симптомов. При отметке **от 0 до 50 мм** ринит считается контролируемым, при отметке **50 мм и более** неконтролируемым.

Подростки и взрослые, ВАШ 50 мм и более (ринит не контролируется): пошаговый алгоритм

1. антигистаминные препараты **на 2–4 недели**;
2. контроль достигнут: лечение по потребности, рассмотреть АСИТ;
3. контроля нет: добавить интраназальный глюкокортикостероид или монтелукаст ещё **на 2–4 недели**;
4. контроль не достигнут и в этом случае: пересмотреть диагноз, искать сопутствующую патологию, рассмотреть АСИТ и хирургическое лечение.

Если сохраняются глазные симптомы, добавляют препараты для лечения аллергического конъюнктивита.

Ринит контролируемый, если за последние 4 недели

1. симптомы отсутствовали;
2. не нарушались сон и дневная активность;
3. результат теста «дыхание с закрытым ртом» нормальный.

Любое отклонение, в том числе учащение потребности в препаратах скорой помощи, означает потерю контроля; возможен переход на ступень выше.

Для проведения теста пациенту предлагается закрыть рот и в течение 30 секунд дышать только носом.

Обострение сопутствующих заболеваний (бронхиальной астмы, синусита, синдрома ночного апноэ) может нарушить контроль ринита.

Решение о снижении объёма терапии принимают, оценивая бессимптомный период на фоне предшествующего лечения за последние **4 недели**.

При ведении дневника симптомов (шкала TNSS, суммарная оценка назальных симптомов) пациент ежедневно оценивает чихание, водянистые выделения, заложенность и зуд от 0 до 3 баллов; суммарный балл составляет от 0 до 12. Врач рассчитывает среднее значение за 7 дней. Дневник ведётся в период обострения и для оценки эффективности АСИТ.

Отдельно оценивается медикаментозная нагрузка: приём только антигистаминных препаратов соответствует 1 баллу, интраназальных глюкокортикостероидов 2 баллам, системных глюкокортикоидов 3 баллам.

---

7. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Каждому пациенту или его представителям следует разъяснить суть заболевания, составить индивидуальный план лечения и обучить навыкам самостоятельного контроля заболевания.

Пациенты подлежат диспансерному наблюдению у аллерголога-иммунолога или оториноларинголога: взрослые **не реже одного раза в год**, дети **не реже двух раз в год**. Наблюдение продолжается пожизненно или до достижения стойкой ремиссии длительностью **3 года и более**.

АСИТ применяется и для вторичной профилактики: она позволяет предупредить развитие бронхиальной астмы, утяжеление течения ринита и расширение спектра сенсибилизации.

При пыльцевой сенсибилизации рекомендуется ограничить употребление перекрёстно реагирующих продуктов и растительных лекарственных средств.

Лечение, как правило, амбулаторное.

Показания к госпитализации

1. крайне тяжёлое или осложнённое течение;
2. у детей тяжёлое обострение с выраженной заложенностью носа;
3. плановое проведение ускоренного курса АСИТ.

Критерии выписки

1. достижение контроля над симптомами, нормализация лабораторных показателей;
2. завершение курса АСИТ.

---

8. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Аллергический ринит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 11.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2027 года

Код в рубрикаторе	261_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

8.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Разовая доза кромоглициевой кислоты указана в КР как «2.8 мкг», суточная как «22.4 мкг»; эти значения следует сверить с инструкцией в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
- Подпись к алгоритму в приложении Г1 гласит «пациентов, получавших лечение ранее», тогда как в оригинальном названии указано «untreated patients», то есть пациенты, не получавшие лечения.

Клинические рекомендации

Анафилактический шок

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**T78.0** — Анафилактический шок, вызванный патологической реакцией на пищу **T78.2** — Анафилактический шок неуточненный **T80.5** — Анафилактический шок, связанный с введением сыворотки **T88.6** — Анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.04.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/263_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Анафилактическим шоком (АШ) называют острую недостаточность кровообращения в результате анафилаксии: систолическое АД снижается **ниже 90 мм рт. ст.** или **на 30% от рабочего уровня**, развивается гипоксия жизненно важных органов.
- Диагноз устанавливается по клинической картине: острое начало характерных симптомов через минуты или часы после контакта с триггером. Учитываются и обстоятельства реакции: введение лекарственного средства, пищевой продукт, ужаление перепончатокрылым.
- **Первые действия**
  1. вызвать скорую медицинскую помощь, в стационаре с отделением реанимации — реанимационную бригаду;
  2. прекратить поступление предполагаемого аллергена;
  3. уложить пациента на спину с приподнятыми нижними конечностями, голову повернуть на бок;
  4. незамедлительно ввести эпинефрин внутримышечно в переднебоковую поверхность верхней трети бедра.
- **Эпинефрин в/м: 0,01 мг/кг, максимальная разовая доза**
  1. взрослые: 0,5 мг;
  2. дети 6–12 лет: 0,3 мг;
  3. дети до 6 лет: 0,15 мг;
  4. повторная доза: при отсутствии ответа **не менее чем через 5 минут**.
- Госпитализация экстренная, в отделение реанимации, на срок **не менее 24 часов**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

1. **анафилаксия** — жизнеугрожающая системная реакция гиперчувствительности немедленного типа с быстрым развитием нарушений гемодинамики и (или) дыхания; возможны поражения кожи, слизистых оболочек и желудочно-кишечного тракта
2. **анафилактический шок** — острая недостаточность кровообращения в результате анафилаксии со снижением систолического АД **ниже 90 мм рт. ст.** или **на 30% от рабочего уровня**

Без выраженных гемодинамических нарушений диагноз шока неправомерен: жизнеугрожающий бронхоспазм в сочетании с крапивницей является анафилаксией, но не анафилактическим шоком.

2.2 Этиология и патогенез

Этиологические факторы

1. лекарственные средства, медицинские препараты и материалы (31,2–46,5%);
2. пищевые продукты (23,3–31%);
3. яд перепончатокрылых насекомых (14,9–20%).

Возможна анафилаксия на яды других животных, например змей. В 24–26% случаев причину установить не удаётся.

Наиболее частые причины

1. **лекарственные средства** — парентеральные антибактериальные препараты системного действия (пенициллины, цефалоспорины), НПВП, йодсодержащие рентгеноконтрастные средства, миорелаксанты, латекс
2. **пищевая анафилаксия** — коровье молоко, рыба и морепродукты, орехи, арахис, яйца
3. **по возрасту** — у детей чаще пищевые продукты, у взрослых — лекарственные средства и яд перепончатокрылых

В основе лежит реакция гиперчувствительности немедленного типа, как правило, с участием иммуноглобулинов Е, фиксированных на мембранах базофилов и тучных клеток (1-й тип по Gell и Coombs).

Частота анафилаксии в общей популяции, по зарубежным данным, составляет 1,5–7,9 на 100 000 населения в год; в Казани частота новых случаев АШ за 2012 г. составила 0,37 на 10 000 населения. Смертность от анафилаксии — до 0,0001%, летальность — до 1%.

2.3 Классификация

Степени тяжести АШ

1. **1-я степень** — гемодинамические нарушения незначительные, АД снижено **на 30–40 мм рт. ст.** от рабочих величин; пациент в сознании; возможны предвестники (зуд кожи, сыпь, першение в горле, кашель), чувство жара, шум в ушах, головная боль, сжимающая боль за грудиной
2. **2-я степень** — АД снижается **ниже 90–60/40 мм рт. ст.**, возможна потеря сознания; кожа бледная, иногда синюшная, одышка, стридорозное дыхание, хрипы в лёгких, глухие тоны сердца, тахикардия; возможны осиплость голоса вплоть до афонии и затруднение глотания
3. **3-я степень** — потеря сознания, АД **60–40/0 мм рт. ст.**; нередко судороги, холодный липкий пот, цианоз губ, расширение зрачков, нитевидный пульс
4. **4-я степень** — АД не определяется, тоны сердца и дыхание не прослушиваются; при остановке кровообращения и дыхания применяется протокол сердечно-лёгочной реанимации

Артериальная гипотония у детей

1. от 1 месяца до 1 года: **менее 70 мм рт. ст.**;
2. от 1 до 10 лет: **менее 70 мм рт. ст. + (2 × возраст в годах)**;
3. от 11 до 17 лет: **менее 90 мм рт. ст.**.

Первым признаком гипотонии у детей может быть быстро нарастающая тахикардия.

Варианты течения

1. **злокачественное** — острое начало с быстрым падением АД (диастолического — до 0 мм рт. ст.), нарушением сознания и нарастанием дыхательной недостаточности с бронхоспазмом; резистентно к интенсивной терапии, исход неблагоприятный
2. **острое доброкачественное** — характерно для типичной формы: оглушение или сопор, умеренные изменения сосудистого тонуса; хороший эффект своевременной терапии
3. **затяжное** — после противошоковой терапии с временным или частичным эффектом; резистентность к терапии, осложнения (пневмония, гепатит, энцефалит); характерно для препаратов пролонгированного действия
4. **рецидивирующее** — повторное шоковое состояние после первоначального купирования симптомов, часто после препаратов пролонгированного действия; рецидивы могут быть тяжелее и резистентнее к терапии
5. **абортивное** — наиболее благоприятное, часто в виде асфиктического варианта; гемодинамические нарушения минимальны, купируется быстро

Клинические варианты по доминирующей симптоматике

1. **типичный** — гемодинамические нарушения в сочетании с поражением кожи и слизистых оболочек (крапивница, ангиоотёк), бронхоспазм
2. **гемодинамический** — гемодинамические нарушения на первом плане или изолированы
3. **асфиктический** — преобладает острая дыхательная недостаточность
4. **абдоминальный** — преобладает поражение органов брюшной полости
5. **церебральный** — преобладает поражение центральной нервной системы

2.4 Клиническая картина

АШ, как правило, развивается **в течение 2 часов** после воздействия аллергена: при пищевой аллергии — **в течение 30 минут**, при парентеральном введении лекарственного средства и ужалении насекомого — быстрее.

Среднее время от первых симптомов до остановки кровообращения при фатальных реакциях

1. пищевые продукты: 30 минут;
2. яды насекомых: 15 минут;
3. парентеральные лекарственные средства: 5 минут.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Достаточно одного из трёх критериев

1. острое начало (от нескольких минут до нескольких часов) с поражением кожи и (или) слизистых оболочек (генерализованная крапивница, зуд, гиперемия, отёк губ, языка, нёбного язычка) в сочетании с респираторными нарушениями или снижением АД;
2. два или более симптома, возникших остро после контакта с возможным аллергеном, при обязательных жизнеугрожающих нарушениях дыхания и (или) кровообращения: поражение кожи и слизистых оболочек, респираторные проявления, внезапное снижение АД, персистирующие гастроинтестинальные нарушения;
3. снижение АД после контакта с известным для пациента аллергеном.

3.2 Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика проводится

1. с другими видами шока: кардиогенным, септическим;
2. с острыми состояниями с артериальной гипотонией, нарушением дыхания и сознания: острая сердечно-сосудистая недостаточность, инфаркт миокарда, синкопальные состояния, тромбоэмболия лёгочной артерии, эпилепсия, солнечный и тепловой удары, гипогликемия, гиповолемия, передозировка лекарственных средств, аспирация;
3. с вазовагальными и психогенными реакциями (истерия, панические атаки);
4. с системным мастоцитозом.

3.3 Жалобы и анамнез

После стабилизации состояния собирают сведения обо всех возможных провоцирующих факторах: анамнез важен для диагноза, установления причины и профилактики повторных реакций.

Что уточняют

1. обстоятельства реакции: введение лекарственного средства, пищевой продукт, ужаление насекомым, проведение АСИТ;
2. время возникновения: внезапное развитие симптомов через минуты или часы после воздействия триггера, быстрое прогрессирование;
3. факторы риска тяжёлого АШ: пожилой возраст, бронхиальная астма и другие хронические заболевания органов дыхания, тяжёлые атопические заболевания, сердечно-сосудистая патология, мастоцитоз, приём бета-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ.

Жалобы зависят от степени тяжести, клинического варианта и течения.

Жалобы при сохранённом сознании

1. кожный зуд, высыпания, отёк глаз и слизистой оболочки полости рта;
2. выделения из носа, чихание, кашель, одышка, боли в груди;
3. боли в животе, в том числе схваткообразные, тошнота, металлический привкус во рту;
4. беспокойство, страх, слабость, головокружение, озноб;
5. онемение языка и пальцев, шум в ушах, ухудшение зрения.

3.4 Физикальное обследование

Обязательным критерием являются жизнеугрожающие нарушения дыхания и (или) снижение АД в сочетании с поражением других органов и систем.

Диагностические признаки

1. **сердечно-сосудистая система** — тахикардия, брадикардия, нарушения ритма, сжимающая боль за грудиной, остановка сердца
2. **кожа и слизистые оболочки** — эритема, генерализованный зуд, уртикарные высыпания, ангиоотёк губ и языка, периорбитальный отёк, конъюнктивит; позднее — бледность, холодный пот, цианоз губ
3. **дыхательная система** — ринит, ринорея, чихание, одышка, кашель, бронхоспазм, дисфония, стридор, отёк дыхательных путей; при отёке гортани возможна асфиксия
4. **центральная нервная система** — головная боль, головокружение, возбуждение или вялость, страх смерти, судороги, потеря сознания, мидриаз
5. **желудочно-кишечный тракт** — боль в животе, тошнота, рвота, диарея

3.5 Сывороточная триптаза

При подозрении на анафилаксию определяют активность сывороточной триптазы **через 15 минут — 3 часа** после первых симптомов и после выздоровления, для дифференциальной диагностики с другими видами шока.

Диагностически значимо повышение триптазы выше значения «1,2 × базальный уровень + 2». Нормальный уровень не исключает АШ; повышение возможно при инфаркте миокарда, травме, эмболии амниотическими водами, мастоцитозе. Для экстренного применения тест в широкой практике недоступен.

3.6 Мониторирование

Всем пациентам при оказании экстренной помощи мониторируют пульс, АД и частоту дыхательных движений; без монитора АД и пульс измеряют вручную **каждые 2–5 минут**.

---

4. Лечение

4.1 Вызов помощи и прекращение поступления аллергена

Вне медицинской организации и в организации без отделения реанимации вызывают скорую медицинскую помощь, в организации с отделением реанимации — реанимационную бригаду.

Прекращение поступления аллергена

1. **внутривенное введение лекарственного средства** — немедленно остановить введение, сохранить венозный доступ
2. **ужаление перепончатокрылым** — удалить жало, выше места ужаления наложить венозный жгут

Если удаление аллергена требует значительного времени (например, промывание желудка), его не выполняют.

4.2 Положение пациента

Пациента укладывают на спину с приподнятыми нижними конечностями, голову поворачивают на бок. Поднимать пациента или переводить в положение сидя нельзя: это в течение нескольких секунд может привести к фатальному исходу.

1. **беременные** — положение на левом боку с обеспечением проходимости верхних дыхательных путей
2. **удушье при бронхоспазме или ангиоотёке верхних дыхательных путей** — положение сидя: если не дать такому пациенту сесть, он может погибнуть

4.3 Эпинефрин

Эпинефрин вводят незамедлительно внутримышечно в переднебоковую поверхность верхней трети бедра, при необходимости через одежду; эта локализация предпочтительнее дельтовидной мышцы и подкожного введения.

При наличии венозного доступа обученный персонал с опытом титрования адренергических средств (анестезиологи-реаниматологи) может начать с внутривенного введения при обязательном ЭКГ-мониторировании.

Доза: 0,01 мг/кг в/м, максимальная разовая

1. взрослые: #эпинефрин 0,5 мг;
2. дети 6–12 лет: 0,3 мг;
3. дети до 6 лет: 0,15 мг.

При отсутствии ответа на первую дозу **не менее чем через 5 минут** вводят повторную дозу #эпинефрина в/м в той же дозе.

При недостаточном ответе на 2 и более дозы в/м эпинефрин вводят внутривенно только при кардиореспираторном мониторинге. Если венозный доступ установить невозможно, в/м введение в той же дозе продолжают **каждые 5–10 минут**.

Внутривенное введение эпинефрина

1. взрослые: 1 мл раствора эпинефрина на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида со скоростью 0,5–1 мл/кг/ч;
2. дети: непрерывное внутривенное введение #эпинефрина 0,1 мкг/кг/мин с титрованием до 1 мкг/кг/мин.

4.4 Кислород и растворы электролитов

Всем пациентам для коррекции гипоксемии проводят ингаляцию кислорода потоком через лицевую маску.

После введения эпинефрина внутривенно вводят растворы электролитов для коррекции относительной гиповолемии, предпочтительно подогретый 0,9% раствор натрия хлорида; рекомендованная доза — 10–30 мл/кг.

1. нормотензия: 500–1000 мл;
2. артериальная гипотензия: 1000–2000 мл;
3. сердечная недостаточность в анамнезе: не более 250 мл за 5–10 минут;
4. дети: 20 мл/кг.

Растворы декстрозы не рекомендуются из-за быстрой экстравазации.

4.5 Кортикостероиды системного действия

Вводятся после стабилизации АД и устранения респираторных проявлений для снижения риска продлённой фазы респираторных проявлений. Длительность и дозу подбирают индивидуально.

1. взрослые: внутривенно #метилпреднизолон 50–100 мг или #гидрокортизон 200 мг; эквивалентные дозы — преднизолон 60–120 мг, дексаметазон 8–16 мг;
2. дети: внутривенно или в/м #метилпреднизолон 1–2 мг/кг (максимум 50 мг), или #гидрокортизон 2–4 мг/кг (максимум 100 мг), или дексаметазон 0,1–0,4 мг/кг (максимум 10 мг); эквивалентная доза преднизолона — 1,3–2,6 мг/кг (максимум 50 мг).

4.6 Антигистаминные препараты системного действия

Применяются после стабилизации АД при поражении кожи и слизистых оболочек: уменьшают проницаемость капилляров, отёк, зуд и гиперемию.

1. взрослые: клемастин 0,1% 2 мл (2 мг) внутривенно или в/м; хлоропирамин 2% 1–2 мл внутривенно или в/м; дифенгидрамин 25–50 мг внутривенно или в/м;
2. дети: #клемастин в/м 25 мкг/кг в сутки в 2 инъекции; #хлоропирамин, начиная с 5 мг (0,25 мл); #дифенгидрамин при массе менее 35–40 кг — 1 мг/кг, максимум 50 мг.

Действие антигистаминных препаратов начинается значительно позже, чем эпинефрина, поэтому немедленное введение пользы не приносит. Быстрое внутривенное введение может усугубить гипотензию: дифенгидрамин вводят медленно, **не менее 5 минут**. Дифенгидрамин запрещён при недоношенности и в период новорождённости.

4.7 Селективные бета2-адреномиметики

При сохраняющемся бронхоспазме, несмотря на введение эпинефрина, проводят ингаляцию через небулайзер: взрослым — раствор сальбутамола 2,5 мг/2,5 мл, детям — раствор #сальбутамола 2,5 мг/2,5 мл.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Всем пациентам после АШ показана консультация аллерголога-иммунолога: выявление аллергена и рекомендации по предотвращению контакта с ним. Пациентов обучают оказанию первой помощи при повторном АШ.

Пациентам с отягощённым аллергологическим анамнезом (бронхиальная астма, хроническая крапивница, анафилаксия в анамнезе) перед операцией или рентгеноконтрастным исследованием проводят премедикацию **за 1 час до вмешательства**.

1. кортикостероид: #дексаметазон 4–8 мг или #преднизолон 30–60 мг в/м или внутривенно капельно на 0,9% растворе натрия хлорида;
2. антигистаминный препарат: #клемастин 0,1% 2 мл или #хлоропирамин 1–2 мл в/м или внутривенно капельно на 0,9% растворе натрия хлорида или 5% растворе декстрозы.

Информация для пациента

1. после АШ на лекарственное средство пациент должен знать причинно-значимые препараты и не применять их;
2. при АШ на ужаление перепончатокрылыми — избегать ужалений и иметь при себе раствор эпинефрина 0,1%, кортикостероиды и антигистаминные препараты;
3. при АШ на пищевые продукты — исключить их и иметь при себе те же препараты.

Противошоковый набор процедурного и стоматологического кабинета

1. раствор эпинефрина 0,1% в ампулах № 10;
2. преднизолон (30 мг), дексаметазон (4 мг) и (или) гидрокортизон 100 мг в ампулах № 10;
3. дифенгидрамин 1%, клемастин 0,1% 2 мл и (или) хлоропирамин 2% 1 мл в ампулах № 10;
4. сальбутамол, дозированный аэрозоль 100 мкг/доза № 2;
5. растворы декстрозы 40% и 5%, натрия хлорида 0,9%, атропина 0,1%, этанол 70%;
6. роторасширитель, языкодержатель, жгут, шприцы, внутривенные катетеры, системы для инфузий, перчатки;
7. воздуховод, ручной дыхательный аппарат (тип АМБУ), ларингеальная маска, надгортанные устройства.

5.2 Показания к госпитализации

При диагностике анафилаксии или АШ показана экстренная госпитализация в стационар с отделением реанимации и интенсивной терапии; пребывание в отделении реанимации — **не менее 24 часов**.

Поскольку затяжное или рецидивирующее течение предсказать невозможно, после купирования госпитализация продолжается **не менее 12–24 часов**, при необходимости — **до 2–3 суток**. Нарушения функции органов могут сохраняться **3–4 недели**, поэтому требуется амбулаторное наблюдение.

5.3 Факторы риска тяжёлой, двухфазной и смертельной анафилаксии

1. **тяжёлая анафилаксия** — возраст старше 65 лет, мужской пол, болезни сердца и лёгких (ХОБЛ, астма), предшествующая анафилаксия, мастоцитоз; триггеры — лекарства, яд насекомых; приём бета-адреноблокаторов или ингибиторов АПФ; интенсивная физическая активность
2. **двухфазная анафилаксия** — предшествующая анафилаксия, неизвестный триггер; большое пульсовое давление, гипотония, свистящее дыхание, диарея; позднее введение эпинефрина или более 1 дозы
3. **смертельная анафилаксия** — пожилой возраст, мужской пол, астма, сердечно-сосудистые заболевания, мастоцитоз, позднее введение эпинефрина

Даже при правильно оказанной помощи возможен летальный исход.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Анафилактический шок»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 14.04.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	263_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Федерация анестезиологов и реаниматологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Скорость внутривенной инфузии эпинефрина у взрослых в рекомендации 21 указана как 0,5–1,0 мл/кг/ч без концентрации раствора; разведение (1 мл 0,1% раствора на 100 мл 0,9% натрия хлорида) приведено только в рекомендации 19.
- Дифенгидрамин детям массой менее 35–40 кг: в рекомендации 25 — 1 мг/кг, в комментарии к ней — «1 мл/кг».
- Хлоропирамин: в рекомендации 25 и в противошоковом наборе — раствор 2%, в рекомендации 29 (премедикация) — «0,2% 1–2 мл».
- Формула диагностически значимого повышения триптазы (1,2 × базальный уровень + 2) приведена в мг/дл; концентрацию триптазы в лабораториях выражают в мкг/л (нг/мл).
- Сроки госпитализации: в разделе «Показания к госпитализации» — в отделении реанимации не менее 24 часов, в разделе «Показания к выписке» — госпитализация не менее 12–24 часов.

Клинические рекомендации

Аномалии и деформации зубочелюстной системы и лицевого черепа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K07.0** — Основные аномалии размеров челюстей **K07.1** — Аномалии челюстно-черепных соотношений **K07.4** — Аномалия прикуса неуточненная **Q18** — Другие врожденные аномалии [пороки развития] лица и шеи
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 29.12.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/779_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Зубочелюстная аномалия (деформация) — диспропорция развития челюстей с функциональными и эстетическими нарушениями; может затрагивать челюсти, скуловые кости, структуры носа и другие кости лицевого черепа.
- Всем пациентам показана консультация оториноларинголога. При нарушении носового дыхания оценивают состояние ЛОР-органов и функцию внешнего дыхания (передняя активная риноманометрия, акустическая ринометрия), а по показаниям выполняют хирургическую коррекцию внутренних структур носа.
- Обязательны КТ лицевого черепа (КЛКТ или МСКТ) и МРТ височно-нижнечелюстного сустава.
- Основным методом лечения скелетных аномалий является хирургический (ортогнатические операции) в сочетании с ортодонтической подготовкой до операции и коррекцией после неё.
- Операцию у пациентов **младше 18 лет** согласуют с ортодонтом с учётом окончания роста.
- Госпитализация плановая, в круглосуточный стационар челюстно-лицевой хирургии.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Термины и определения

Термин	Определение
Аномалия	врождённое отклонение от нормы или общей закономерности
Деформация	изменение размеров, формы и конфигурации кости от внешних или внутренних факторов
Окклюзия	вид смыкания зубных рядов
Прикус	соотношение челюстей в положении центральной окклюзии
Дистальная окклюзия	нижний зубной ряд смещён назад относительно верхнего, резцовая дизокклюзия, нарушение соотношения боковых зубов в сагиттальном направлении
Мезиальная окклюзия	нижняя челюсть смещена вперёд относительно верхней
Вертикальная резцовая дизокклюзия	нет окклюзионных контактов между резцами
Ортогнатическая хирургия	нормализация формы, размеров, положения и соотношения челюстей; включает и приёмы для профилактики нарушения носового дыхания
Гениопластика	остеотомия подбородочного отдела нижней челюсти для изменения контуров подбородка, по эстетическим показаниям

2.2 Классификация

Рабочая классификация скелетных зубочелюстных аномалий

1. **по типу окклюзии в сагиттальной плоскости**: дистальная или мезиальная окклюзия;
2. **по типу окклюзии в трансверсальной плоскости**: перекрёстная окклюзия;
3. **по типу окклюзии в вертикальной плоскости во фронтальном участке**: вертикальная резцовая дизокклюзия;
4. **по межчелюстному соотношению**: II скелетный класс (дистальный прикус), III скелетный класс (мезиальный прикус), сужение челюсти (перекрёстная окклюзия);
5. **по симметричности**: симметричная, асимметричная.

2.3 Этиология

Патология размеров и формы челюстей наблюдается при

1. наследственной предрасположенности и генетических заболеваниях;
2. врождённых аномалиях челюстно-лицевой области: расщелины губы, альвеолярного отростка и нёба, гемифациальная микросомия, синдромы Робена и Гольденхара;
3. нарушениях развития височно-нижнечелюстных суставов;
4. травмах челюстей с поражением зон роста;
5. рахите, нарушениях обмена кальция, эндокринопатиях.

Менее значимые причины

1. нарушение носового дыхания;
2. макроглоссия;
3. неправильное грудное вскармливание;
4. осложнения кариеса, недостаточная жевательная нагрузка, связанная с диспропорцией размеров зубов и отдельных участков челюстей.

Согласно современным представлениям, причинами зубочелюстных аномалий могут быть также

1. воспалительные и опухолевые процессы;
2. факторы внешней среды;
3. парафункции и вредные привычки.

2.4 Клиническая картина

У взрослых клиническая картина, как правило, сложнее, чем у детей: к аномалии присоединяются потеря зубов, деформация зубных рядов и челюстей, функциональная перегрузка пародонта, нарушения окклюзии.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза;
2. клинической оценки состояния пациента, местного и стоматологического статуса;
3. оценки моделей зубных рядов;
4. антропометрического анализа;
5. лучевых методов исследования: ОПТГ, ТРГ, КЛКТ или МСКТ, МРТ.

Дополнительно оценивают

1. соматический статус;
2. психоневрологический статус при нелабильной психике.

3.1 Жалобы и анамнез

Выяснить жалобы на

1. изменение конфигурации челюстей или лица, асимметрию челюстей и лица;
2. частичную потерю зубов;
3. затруднение движений нижней челюсти и жевания;
4. хруст, щелчки, боль в височно-нижнечелюстных суставах;
5. нарушение носового дыхания;
6. реже — дефект речи.

3.2 Осмотр и антропометрические измерения лица

Начать с оценки симметрии лицевого скелета и черепа, определения прикуса и антропометрических измерений лица.

Видимая деформация, асимметрия лица, нарушение окклюзии и межчелюстных соотношений — первичное звено обследования. Антропометрия объективно оценивает выраженность аномалии, гипсовые модели зубных рядов — прикус.

3.3 Лабораторные исследования перед операцией

При подготовке к операции выполняют лабораторные исследования, чтобы исключить сопутствующие заболевания.

3.4 КТ лицевого черепа

КТ лицевого отдела черепа (КЛКТ или МСКТ), с трёхмерной реконструкцией или без неё, выполняется у всех пациентов; шаг или толщина среза — **не более 0,5 мм**. Без КЛКТ или МСКТ диагностика невозможна.

3.5 МРТ височно-нижнечелюстного сустава

МРТ височно-нижнечелюстного сустава выполняется у всех пациентов для оценки целостности и положения суставного диска.

3.6 Консультации специалистов

Всем пациентам показана консультация оториноларинголога: он оценивает состояние ЛОР-органов и предупреждает осложнения с их стороны.

При нарушении носового дыхания оценивают функцию внешнего дыхания методами передней активной риноманометрии и акустической ринометрии.

Консультация ортодонта необходима каждому пациенту, поскольку хирургическое лечение всегда сопровождается ортодонтической подготовкой и коррекцией после операции.

Консультация генетика рекомендована всем для выявления синдрома или нарушения костного метаболизма.

Перед операцией необходима консультация анестезиолога-реаниматолога: операции травматичны, возможна значительная кровопотеря и гемотрансфузия.

Перед операцией стоматолог-терапевт проводит подготовку зубов.

Стоматолог-ортопед осматривает всех пациентов: оценивает дефекты зубных рядов и окклюзионные соотношения.

---

4. Лечение

Рекомендованным методом лечения скелетных зубочелюстных аномалий является хирургический.

Противопоказанием являются тяжёлые заболевания в стадии декомпенсации. После их лечения операция становится возможной.

Пациентам **младше 18 лет** операцию согласуют с ортодонтом с учётом окончания роста, чтобы предупредить рецидив.

4.1 Общие принципы

Единого универсального метода не существует: объём операции планируют индивидуально с учётом типа и выраженности аномалии, этнической принадлежности и возраста.

Лечение направлено на устранение аномалии и создание условий для нормальной работы зубочелюстной системы. Независимо от степени внешней аномалии, перед лечением оценивают параметры всего лицевого скелета.

Перед операцией планируют объём и методики вмешательства.

Перемещение челюстей и изменение мягких тканей лица рассчитывают до операции в специализированных компьютерных программах.

Во время ортогнатической операции применяют жёсткую фиксацию титановыми пластинами и винтами: она обеспечивает стабильный результат и снижает риск рецидива.

Хирургическое лечение сочетают с ортодонтической подготовкой до операции и ортодонтической коррекцией после неё.

Этапы комбинированного лечения

1. как правило, лечение трёхэтапное: ортодонтическая подготовка, ортогнатическая операция, завершающее ортодонтическое лечение;
2. при выраженных аномалиях возможно двухэтапное лечение: сначала ортогнатическая операция, затем завершающая ортодонтическая коррекция.

В некоторых случаях применяют метод «surgery first», без предоперационной ортодонтической подготовки.

4.2 III класс: избыточный рост нижней челюсти

Показана двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) для уменьшения её размеров.

При чрезмерном размере подбородочного отдела выполняется редукционная гениопластика по эстетическим показаниям.

4.3 III класс: недоразвитие верхней челюсти (нормальный или гиподивергентный тип роста)

Всем пациентам рекомендована остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, возможна сегментарная.

При чрезмерном размере подбородочного отдела выполняется редукционная гениопластика по эстетическим показаниям.

4.4 III класс: избыток нижней и недоразвитие верхней челюсти

Объём хирургического вмешательства

1. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, возможна сегментарная, для увеличения верхней челюсти;
2. двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) для уменьшения нижней челюсти;
3. при большом подбородочном отделе — редукционная гениопластика по эстетическим показаниям.

4.5 II класс: избыток верхней (гипердивергентный тип роста) и недоразвитие нижней челюсти

Объём хирургического вмешательства

1. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, возможна сегментарная, для уменьшения верхней челюсти;
2. двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) для увеличения нижней челюсти;
3. остеотомия подбородочного отдела по эстетическим показаниям.

При выраженной «десневой улыбке» выполняется ротация верхней челюсти против часовой стрелки.

4.6 II класс: недоразвитие нижней челюсти

Показана двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) для увеличения её размеров.

Всем пациентам рекомендована также остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I.

При недостаточном размере подбородочного отдела выполняется увеличивающая гениопластика по эстетическим показаниям.

4.7 Сужение верхней челюсти, перекрёстная окклюзия

Лечебная тактика

1. оценить возраст и степень сращения нёбного шва;
2. вместе с ортодонтом решить, возможно ли ортодонтическое расширение;
3. при сращённом шве или невозможности расширения — остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I и по срединному нёбному шву с дистракционным аппаратом; величину расширения определяет ортодонт.

4.8 Вертикальная резцовая дизокклюзия

Объём хирургического вмешательства

1. сегментарная остеотомия верхней челюсти с ротацией фронтального фрагмента из 4 или 6 зубов для предотвращения рецидива в послеоперационном периоде;
2. специальная ортодонтическая подготовка: создание промежутков (трем) между зубами в местах планируемой остеотомии, чтобы не повредить корни зубов;
3. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, BSSO, остеотомия подбородочного отдела.

4.9 Асимметричные аномалии

Лечебная тактика

1. по КЛКТ или МСКТ в специализированной программе оценить возможную послеоперационную деформацию;
2. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, BSSO, остеотомия подбородочного отдела по эстетическим показаниям; при симметричном положении одной из челюстей — одночелюстная операция.

Остаточную асимметрию после перемещения челюстей устраняют краевой резекцией или аугментацией.

4.10 Иное лечение

При нарушении носового дыхания по показаниям выполняется хирургическая коррекция внутренних структур носа.

При патологии височно-нижнечелюстного сустава

1. артроцентез;
2. артролаваж;
3. диагностическая артроскопия.

Для улучшения эстетических параметров оценивают показания к

1. липосакции;
2. липофилингу;
3. платизмопластике;
4. ботулинотерапии;
5. другим методам пластической хирургии.

4.11 Послеоперационное ведение

В раннем послеоперационном периоде

1. **межчелюстная эластическая тяга**: накладывается, как правило, **в первые сутки** и полностью исключает открывание рта, удерживая челюсти в правильном положении;
2. **местно холод**: **в первые сутки** для профилактики отёка;
3. **лекарственная терапия**: курс антибактериальной, противоотёчной и обезболивающей терапии;
4. **гигиена полости рта**: ежедневно.

В первые дни в послеоперационных ранах могут оставлять дренажи; их удаляют на 1–3-и сутки по мере уменьшения отделяемого.

Ограничение открывания рта

1. **операции на верхней челюсти**: как правило, **2 недели**;
2. **ортогнатические операции на нижней челюсти**: около **3 недель**.

После снятия межчелюстной эластической тяги для профилактики ограничения открывания рта рекомендованы лечебная физкультура и физиотерапия.

Для постепенного увеличения амплитуды пациент открывает и закрывает рот перед зеркалом, выполняет движения нижней челюсти вперёд-назад и в стороны; амплитуду можно увеличивать указательным и большим пальцами, расположенными на режущих краях верхних и нижних резцов.

Как правило, через **3–4 недели** после операции пациента направляют к ортодонту на окончательный этап аппаратной ортодонтической коррекции.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации и выписке

5.1 Показания к госпитализации

Ортогнатические операции выполняются челюстно-лицевыми хирургами в круглосуточном стационаре, госпитализация плановая.

Показания к плановой госпитализации

1. необходимость ортогнатической операции или невозможность ортодонтической коррекции в амбулаторных условиях;
2. невозможность выполнения диагностических или лечебных манипуляций в амбулаторных условиях.

Продолжительность госпитализации, как правило, от нескольких дней до двух недель и зависит от течения ближайшего послеоперационного периода.

5.2 Показания к выписке пациента

1. отсутствие показаний к дальнейшему лечению в стационаре;
2. перевод в другое лечебное учреждение;
3. требование пациента или его законного представителя;
4. несоблюдение предписаний или правил внутреннего распорядка, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих.

После выписки пациент наблюдается амбулаторно или в условиях дневного стационара.

5.3 Медицинская реабилитация

После операции показаны реабилитационные мероприятия до полного социального и физического восстановления.

Специфической реабилитации нет. Помощь оказывает команда: челюстно-лицевой хирург, ортодонт, анестезиолог-реаниматолог, при необходимости невролог, офтальмолог, оториноларинголог, генетик, логопед.

5.4 Профилактика и диспансерное наблюдение

При симптомах аномалии костей черепа и лица показана консультация челюстно-лицевого хирурга. Специфической профилактики нет; она заключается в плановом рациональном ведении беременности, а при выявлении аномалии — в обследовании у ортодонта.

После операции челюстно-лицевой хирург и ортодонт осматривают пациента **не реже раза в 6 месяцев**.

При подозрении на рецидив, вторичную деформацию или ухудшение местного, неврологического, офтальмологического статуса выполняют

1. КТ всего черепа;
2. МРТ головного мозга;
3. ЭЭГ;
4. другие исследования по клинической картине.

5.5 Факторы, влияющие на исход лечения

Отрицательно влияют на исход лечения

1. инфекционные осложнения;
2. несоблюдение местной контактной криотерапии;
3. плохая гигиена полости рта;
4. нарушение диеты и ограничения жевательной активности;
5. несоблюдение ношения межчелюстной эластической тяги;
6. несоблюдение лечебной физкультуры;
7. пропуск контрольных осмотров и других рекомендаций врача.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Врожденные и приобретенные аномалии и деформации зубочелюстной системы и лицевого черепа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 29.12.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2026 года
Код в рубрикаторе	779_1 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Рекомендации для взрослых, но в разделе 3 есть указание об операциях у пациентов младше 18 лет — с согласованием с ортодонтом.
- Текст PDF — скан с ошибками распознавания (Le Fort I, BSSO); цитаты журнала сверки приведены по распознанному тексту.

Клинические рекомендации

Болезнь Меньера

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H81.0** — Болезнь Меньера
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/18_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Достоверная болезнь Меньера:
  1. **не менее двух** спонтанных приступов головокружения длительностью **от 20 минут до 12 часов**;
  2. сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа;
  3. флюктуирующие слуховые симптомы: слух, шум, ощущение полноты в ухе;
  4. отсутствие других причин.
- Обследование всех пациентов:
  1. тональная пороговая аудиометрия: степень тугоухости;
  2. импедансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия): исключение патологии среднего уха.
- Купирование приступа:
  1. атропин или платифиллин подкожно;
  2. антигистаминные: дименгидринат, дифенгидрамин;
  3. бензодиазепины: лоразепам, диазепам.

  Не более **3 суток**; из-за тошноты и рвоты предпочтительно парентеральное введение.
- Межприступный период: бетагистин по 24 мг 2 раза в сутки **2–3 месяца и более** после перенесённого приступа и при повторении приступов **чаще одного раза в 3 месяца**.
- Хирургическое лечение при неэффективности консервативного **в течение 6–12 месяцев**:
  1. первый этап: слухосохраняющие вмешательства;
  2. второй этап или социально незначимый слух: деструктивные вмешательства.
- Компьютерная томография (КТ) височных костей и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с выведением внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов выполняют для исключения новообразований, прежде всего акустической шванномы при односторонней сенсоневральной тугоухости.
- Лечение амбулаторное. Показания к госпитализации в оториноларингологическое отделение: тяжёлое состояние пациента или тяжёлое течение заболевания. Критерии выписки: урежение или прекращение приступов головокружения, улучшение или стабилизация порогов слуха.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Болезнь Меньера (БМ) является заболеванием внутреннего уха, которое характеризуется повторяющимися приступами системного головокружения, а также шумом в ушах и сенсоневральной тугоухостью.

2.2 Классификация

Формы по классификации AAO-HNS

1. несомненная;
2. достоверная;
3. вероятная;
4. возможная.

Варианты начала

1. кохлеарная форма: сначала слуховые расстройства, затем вестибулярные;
2. классический вариант: слуховые и вестибулярные нарушения одновременно, уже первый приступ сопровождается снижением слуха и шумом;
3. вестибулярная форма (реже): сначала приступы головокружения, слуховые расстройства позже.

По данным ряда авторов, флюктуация слуха в сочетании с головокружением наблюдается у 82,7% пациентов, без головокружения у 17,3%; по другим данным, заболевание начинается с изолированной кохлеарной симптоматики у 54,4% пациентов, с классической картины у 45,6%.

2.3 Клиническая картина

Триада

1. приступы системного головокружения;
2. шум в ухе;
3. тугоухость.

Приступ

1. развивается внезапно, в любое время, на фоне полного здоровья, ничем не провоцируется;
2. иногда предшествует аура: появление или усиление заложенности и шума в поражённом ухе;
3. всегда сопровождается вегетативными проявлениями, прежде всего тошнотой и рвотой;
4. длится несколько часов (чаще 4–6) и проходит самостоятельно, без препаратов;
5. шум в ухе односторонний, чаще низко- или среднечастотный, усиливается перед приступом и во время него.

Тугоухость, как правило, односторонняя и флюктуирующая. Её аудиологические признаки приведены в разделе «Диагностика» (тональная аудиометрия).

2.4 Стадии заболевания

Первая стадия (начальная)

1. приступы редкие: 1–2 раза в год или раз в 2–3 года, в среднем 1–3 часа, с тошнотой и рвотой;
2. шум, заложенность, распирание в ухе до или во время приступа, но не постоянно;
3. флюктуация слуха: ухудшение перед приступом и последующее улучшение; у некоторых пациентов слух резко улучшается сразу после приступа и снижается до прежнего уровня в течение суток.

Вторая стадия (разгар)

1. типичные приступы с интенсивным системным головокружением и выраженными вегетативными проявлениями;
2. частота: от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю или ежедневно;
3. постоянный шум в ухе, усиливающийся во время приступа;
4. ежедневная заложенность и дискомфорт в ухе;
5. слух снижается от приступа к приступу.

Третья стадия (затухающая)

1. типичные приступы урежаются или прекращаются;
2. постоянная шаткость и неустойчивость;
3. выраженное снижение слуха на поражённое ухо, часто вовлекается второе ухо;
4. возможны отолитовые кризы Тумаркина: внезапные падения вследствие резкого смещения отолитовых рецепторов, опасные травмами.

Длительность приступа в тексте рекомендации указана неодинаково: в общем описании клинической картины она составляет несколько часов (чаще 4–6), для первой стадии в среднем 1–3 часа, в диагностических критериях от 20 минут до 12 часов.

2.5 Степень тяжести

Степени тяжести (частота и длительность приступов, трудоспособность)

1. тяжёлая: приступы ежедневные или еженедельные, по несколько часов, со всем комплексом статокинетических и вегетативных расстройств; трудоспособность утрачена;
2. средняя: приступы еженедельные или ежемесячные, по несколько часов, статокинетические расстройства умеренные, вегетативные выражены; трудоспособность утрачивается во время приступа и на несколько часов после;
3. лёгкая: приступы непродолжительные, ремиссии месяцы и годы.

2.6 Жалобы

Жалобы

1. приступы нарастающей глухоты;
2. шум в ушах;
3. периодическая потеря равновесия;
4. головокружение;
5. тошнота вплоть до рвоты.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают по одной из систем критериев:

1. AAO-HNS (1972, 1985, 1995);
2. критерии 2015 года, согласованным Обществом Барани, Европейской академией отологии и нейроотологии (EAONO), комитетом по равновесию AAO-HNS и Корейским обществом равновесия.

3.1 Диагностические критерии

Форма	Критерии
Несомненная	1. гистологически подтверждённый эндолимфатический гидропс; 2. не менее двух приступов головокружения от 20 минут до 12 часов; 3. сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; 4. флюктуирующие слуховые симптомы: слух, шум, ощущение полноты в ухе.
Достоверная	1. не менее двух спонтанных приступов головокружения от 20 минут до 12 часов; 2. сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; 3. флюктуирующие слуховые симптомы; 4. отсутствие других причин.
Вероятная	1. не менее одного приступа головокружения; 2. сенсоневральная тугоухость, подтверждённая хотя бы однократной аудиометрией; 3. шум или заложенность в поражённом ухе; 4. отсутствие других причин.

Форма	Критерии
Возможная	1. приступы головокружения без подтверждённого снижения слуха либо стойкая или непостоянная сенсоневральная тугоухость с нарушением равновесия без явных приступов; 2. отсутствие других причин.

3.2 Физикальное обследование: акуметрия и вестибулярные пробы

Комплексное общеклиническое обследование с участием терапевта и невролога.

Методы исследования

1. акуметрия: шёпотная и разговорная речь, камертональные пробы Вебера, Ринне и Федериче;
2. оценка спонтанного нистагма;
3. тест импульсного поворота головы (Хальмаги–Кертойза);
4. статокоординаторные и статокинетические пробы: поза Ромберга, проба Фишера–Барре, ходьба по прямой и фланговая походка, проба на диадохокинез;
5. позиционные пробы: Дикса–Холлпайка, roll-тест Пагнини–Макклюра.

3.3 Общий и биохимический анализы крови

Показания

1. дифференциальная диагностика.

Выполняют общий (клинический) и биохимический общетерапевтический анализы крови.

3.4 Тональная аудиометрия и импедансометрия

Показания: все пациенты

1. тональная пороговая аудиометрия: определение степени тугоухости;
2. импедансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия): исключение патологии среднего уха.

Диагностические признаки

1. скалярная (ложная сенсоневральная) тугоухость: горизонтальный или восходящий тип кривой с костно-воздушным интервалом 5–10 дБ на низких или средних частотах;
2. пороги восприятия ультразвука в норме, латерализация ультразвука в сторону хуже слышащего уха;
3. возможно снижение амплитуды пиков спонтанной отоакустической эмиссии.

При ретрокохлеарном уровне поражения отмечается повышение порогов акустического рефлекса относительно нормальных порогов слышимости.

3.5 Подтверждение гидропса лабиринта

Показания к подтверждению гидропса лабиринта

1. клинические признаки вероятной болезни Меньера;
2. неэффективность консервативной терапии.

Методы (по отдельности или в сочетании)

1. пороги чувствительности к ультразвуку и его латерализация;
2. электрокохлеография (ЭКоГ);
3. дегидратационный тест.

Универсального метода выявления гидропса лабиринта не существует. Для подтверждения диагноза необходим широкий спектр исследований с оценкой результатов в динамике, при этом результаты в значительной степени зависят от стадии заболевания.

3.6 Отоакустическая эмиссия и КСВП

Показания к отоакустической эмиссии и коротколатентным слуховым вызванным потенциалам (КСВП)

1. противопоказания к МРТ головного мозга (например, металлические конструкции);
2. сомнительные результаты тональной аудиометрии: подозрение на аггравацию или симуляцию.

Критериями ретрокохлеарной дисфункции по данным КСВП являются отсутствие всех пиков с I по V, которое трудно объяснить потерей слуха; отсутствие всех пиков, следующих за I или III; удлинение межпикового интервала I–V более 4,4 мс; снижение отношения амплитуд V/I менее 0,5, особенно в сочетании с другими изменениями. Диагностическое значение имеет также патологически большая межауральная разница параметров, особенно межпиковых интервалов, если её трудно объяснить односторонней или асимметричной тугоухостью периферического уровня.

3.7 Вестибулярные исследования

Показания

1. диагноз невозможно установить по клиническим данным;
2. планирование хирургического лечения.

Межприступный период

1. спонтанной вестибулярной симптоматики нет;
2. статическое и динамическое равновесие в норме, в том числе по постурографии (стабилографии);
3. при вестибулометрии угнетение вестибулярной функции, больше на стороне поражения.

Приступ: периферический вестибулярный синдром

1. системное головокружение;
2. тошнота, рвота;
3. нарушение равновесия;
4. горизонтальный вестибулярный нистагм.

Показания к видеонистагмографии (ВНГ)

1. дифференциальная диагностика;
2. планирование хирургического лечения.

Запись калорической или вращательной пробы, видеоимпульсного и других тестов.

3.8 Лучевые методы исследования

Показаны КТ височных костей и МРТ головного мозга с выведением внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов, в том числе с контрастированием.

Цель: исключить

1. новообразования, при односторонней сенсоневральной тугоухости прежде всего акустическую шванному;
2. демиелинизирующий процесс;
3. нейроваскулярный конфликт;
4. приобретённые и врождённые структурные изменения височных костей.

3.9 Дифференциальная диагностика

Диагноз	Отличительные признаки
Болезнь Меньера	Приступы системного головокружения, сопровождающиеся снижением слуха, ощущением распирания и шумом в ухе, тошнотой и рвотой

Диагноз	Отличительные признаки
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ)	Кратковременные приступы системного головокружения, возникающие при изменении положения тела
Вестибулярный нейронит	Резко выраженное вращательное головокружение, расстройство равновесия, тошнота и рвота на фоне вирусной инфекции
Перилимфатическая фистула	Головокружение различной степени выраженности и нарушения слуха вплоть до глухоты после травмы уха или на фоне хронического отита; симптомы провоцируются изменением давления или громкими звуками
Инфаркт лабиринта	Острое системное головокружение, часто в сочетании с острой односторонней глухотой и шумом в ухе
Аутоиммунные заболевания внутреннего уха	Прогрессирующее головокружение преимущественно вестибулярного характера с двусторонним снижением слуха и другими признаками аутоиммунного заболевания
Вестибулярная мигрень	Мигренозная головная боль при части приступов головокружения

4. Лечение

Лечение включает три направления: медикаментозное купирование приступа головокружения, медикаментозную профилактику в межприступном периоде и хирургическое лечение.

4.1 Купирование приступа

1. #Атропин или #платифиллин подкожно: блокируют афферентную импульсацию от раздражённого лабиринта. Пометка off-label (в КР — знак #) обозначает применение вне инструкции.
2. Для купирования приступа применяют дименгидринат или дифенгидрамин.

   Препараты относятся к Н1-антигистаминным средствам, проникают через гематоэнцефалический барьер и действуют как вестибулярные блокаторы центрального действия. Их используют в первые сутки приступа, максимально **до 3 суток**.
3. Назначают #лоразепам или #диазепам в первые сутки, **максимально до 3 суток**.

   Ввиду тошноты и рвоты во время приступа предпочтительно парентеральное введение препаратов; по мере купирования симптомов возможен переход на таблетированные формы.

Препарат	Доза
#Атропин	1 мл 0,1% раствора подкожно
#Платифиллин	2 мл 0,2% раствора подкожно
Дименгидринат	50–100 мг 2–3 раза в сутки
Дифенгидрамин	25–50 мг внутрь 3–4 раза в сутки; внутримышечно — #дифенгидрамин 10–50 мг
#Лоразепам	1 мг, возможно сублингвальное применение
#Диазепам	10 мг внутримышечно

4.2 Межприступный период

Бетагистин по 24 мг 2 раза в сутки (48 мг в сутки), курс **2–3 месяца и более**.

Показания

1. после перенесённого приступа головокружения;
2. межприступный период **менее 3 месяцев**.

Бетагистин улучшает кровообращение в сосудистой полоске внутреннего уха, снижает возбудимость нейронов вестибулярных ядер и ускоряет восстановление вестибулярной функции, в том числе за счёт активации центральной вестибулярной компенсации.

Назначают курсами диуретики (калийсберегающие, тиазидные и другие) или ингибиторы карбоангидразы, оптимально ацетазоламид. Петлевые диуретики не применяются ввиду возможного ототоксического действия.

Пример схемы ацетазоламида из рекомендации

1. 1–3-й день: по 1 таблетке 2 раза в день (утром и днём);
2. 7–9-й и 13–15-й дни: по 1 таблетке утром.

Курс подбирают индивидуально.

При длительном приёме ацетазоламида следует контролировать уровень электролитов крови и при необходимости восполнять их.

Диетотерапия всем пациентам:

1. поваренная соль **до 2 г в сутки**;
2. исключение глутамата натрия;
3. сбалансированное питание для нормализации водно-солевого обмена.

Потребление соли и готовых продуктов следует максимально ограничить, алкоголь, кофеин и никотин исключить, жидкость потреблять умеренно.

Плановую инфузионную дегидратационную терапию проводят в первые 2 года заболевания **каждые 6–12 месяцев**, затем **каждые 2–3 года**. Конкретные препараты в рекомендации не указаны.

4.3 Хирургическое лечение

Показание: неэффективность консервативной терапии **в течение 6–12 месяцев**.

Первый этап: слухосохраняющие вмешательства (I и II стадии)

1. хордоплексустомия;
2. интратимпанальное введение глюкокортикоидов;
3. обнажение (дренирование) эндолимфатического мешка;
4. селективная лазеродеструкция ампулярного рецептора горизонтального полукружного канала.

Второй этап: деструктивные вмешательства

1. интратимпанальное введение гентамицина;
2. лазеродеструкция лабиринта;
3. вестибулярная нейроэктомия.

Показания: неэффективность слухосохраняющей операции или социально незначимый слух.

4.4 Медицинская реабилитация

1. нарушение равновесия в межприступном периоде на третьей стадии: лечебная физкультура;
2. двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость со средними порогами в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе **выше 31 дБ**: слухопротезирование.

При развитии соматоформных расстройств на фоне хронической вестибулярной дисфункции показана психолого-социальная реабилитация.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Диспансерное наблюдение предусматривает **ежегодный** осмотр с оценкой эффективности терапии, слуховой и вестибулярной функции.

К мерам профилактики рекомендация относит формирование здорового образа жизни, раннее выявление воспалительных заболеваний ЛОР-органов, особенно у детей, и предупреждение рецидивов хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов посредством диспансерного наблюдения.

Рекомендации пациенту

1. избегать резких перепадов давления в среднем ухе: подводное плавание, резкое сморкание, авиаперелёты;
2. ограничить углеводы, солёные, острые и жирные мясные продукты; ежедневно включать в рацион продукты, богатые калием (печёный картофель, творог, курага);
3. исключить продукты с консервантами;
4. избегать переутомления, работы на высоте и с движущимися предметами.

Ограничения соли, глутамата натрия, алкоголя, кофеина и никотина приведены в разделе «Лечение» (диетотерапия).

5.1 Организация медицинской помощи

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-оториноларингологом в амбулаторных условиях.

Показания к госпитализации в оториноларингологическое отделение

1. тяжёлое состояние пациента;
2. тяжёлое течение: госпитализация бригадой скорой помощи напрямую в специализированное отделение, минуя амбулаторное звено.

Критерии выписки

1. прекращение или урежение приступов головокружения;
2. улучшение или стабилизация порогов слуха.

На течение и исход заболевания влияют его длительность и тяжесть, сопутствующая патология, возраст пациента, наличие и характер осложнений.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Болезнь Меньера»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «пересмотр не позднее 2026 года»; в приложении А2 — обновление каждые 3 года
Код в рубрикаторе	18_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность приступа указана неодинаково: в описании клинической картины «чаще 4-6 ч.», для первой стадии «в среднем от 1 до 3 часов», в диагностических критериях от 20 минут до 12 часов.
- Схема применения ацетазоламида приведена в таблетках, без указания дозы в миллиграммах.

- Для плановой инфузионной дегидратационной терапии (раздел 6) не названы препараты и не указаны УУР и УДД; уровни не указаны также для рекомендаций по хирургическому лечению и диспансерному наблюдению.

Клинические рекомендации

Вирусные менингиты у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**A87.0** — Энтеровирусный менингит (G02.0*) **A87.1** — Аденовирусный менингит (G02.0*) **A87.2** — Лимфоцитарный хориоменингит **A87.8** — Другой вирусный менингит **A87.9** — Вирусный менингит неуточненный **B00.3** — Герпетический менингит (G02.0*) **B01.0** — Ветряная оспа с менингитом (G02.0*) **B02.1** — Опоясывающий лишай с менингитом (G02.0*) **B05.1** — Корь, осложненная менингитом (G02.0*) **B26.1** — Паротитный менингит (G02.0*) **G02.0** — Менингит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках **G03.9** — Менингит неуточненный
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/995_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Вирусный менингит протекает с серозным воспалением оболочек мозга и гипертензионно-гидроцефальным синдромом. Чаще всего его вызывают энтеровирусы (до 58%), герпесвирусы, реже аденовирус, вирусы кори, паротита, гриппа.
- Диагноз основан на клинике (общемозговые, менингеальные, очаговые симптомы после инкубационного периода **2–30 дней**), обнаружении антител IgM или нарастании IgG и вирусной РНК/ДНК методом ПЦР в крови и цереброспинальной жидкости, эпидемиологическом анамнезе. Спинномозговая пункция — **в первые сутки** при отсутствии противопоказаний.
- Для оториноларинголога: при паротитном менингите часто развивается неврит VIII пары черепных нервов — системное головокружение, рвота, нистагм; при тяжёлом течении и подозрении на нейросенсорную тугоухость регистрируются акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП).
- При подозрении на вирусный менингит показана экстренная госпитализация в инфекционный стационар с ОРИТ. Лечение — этиотропное (противовирусные препараты, интерферон альфа-2b), патогенетическое и симптоматическое; антибиотики — только при бактериальных осложнениях.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Вирусный менингит (ВМ) — полиэтиологичное вирусное заболевание, характеризующееся серозным воспалением в оболочках головного мозга с преобладанием гипертензионно-гидроцефального синдрома.

2.2 Этиология и эпидемиология

ВМ развиваются при любых вирусных инфекциях с вовлечением нервной системы в результате нарушения проницаемости гематоэнцефалического барьера. Наиболее частые причины — энтеровирусы и герпесвирусы, реже аденовирус, вирусы кори, эпидемического паротита, гриппа. Вакцинация снижает вероятность неврологических осложнений.

Входными воротами инфекции при первичном ВМ является слизистая оболочка носоглотки, бронхов, желудочно-кишечного тракта; вторичные ВМ носят иммунокомплексный и аллергический характер.

У детей ВМ встречаются в 5–8 раз чаще, чем у взрослых, чаще у мальчиков. В этиологии преобладают энтеровирусы (до 58%), с пиком заболеваемости в июне — октябре.

2.3 Классификация

1. **по первичному очагу** — первичные (энтеровирусные, лимфоцитарный хориоменингит, клещевой энцефалит) и вторичные (грипп, герпес, ВИЧ и другие инфекции)
2. **по течению** — острое — санация ЦСЖ **в течение 4 недель**, затяжное — **4–12 недель**, хроническое — **более 3 месяцев**
3. **по этиологии** — энтеровирусный, лимфоцитарный хориоменингит, герпесвирусный, паротитный, гриппозный, аденовирусный, вызванный вирусами кори, краснухи, клещевого энцефалита, ВИЧ и др.

1. **по форме** — начальный (цитоз 15–50×10^6/л) и выраженный
2. **по тяжести** — среднетяжёлое (плеоцитоз до 150×10^6/л, белок до 0,7 г/л, без осложнений) и тяжёлое
3. **осложнения** — внутричерепная гипертензия, гидроцефальный синдром, диэнцефальный синдром

2.4 Клиническая картина

Клиническая картина любого ВМ — сочетание общемозговой симптоматики, менингеального и общеинфекционного синдромов, а при поражении вещества мозга — очагового синдрома.

При энтеровирусном менингите у 25–90% пациентов отмечаются экзантема, энантема, миалгии, лихорадка двухволновая. У 15–20% детей менингеальных симптомов нет, но есть головная боль, рвота и светобоязнь.

1. **ЦСЖ** — прозрачная, давление 300–400 мм вод. ст., лимфоцитарный плеоцитоз 30–800 клеток в 1 мкл
2. **санация ЦСЖ** — **на 14–20 сутки**
3. **новорождённые и дети до 2–3 месяцев** — ВМ протекает по типу неонатального сепсиса

ВМ, вызванные Коксаки В, реже Коксаки А, ECHO, ЭВИ-71, протекают тяжелее, особенно **у детей до 5 лет**. Течение двухфазное.

1. **первая фаза** — синдром «рука — нога — рот», катаральные явления по типу ринофарингита
2. **вторая фаза** — **на 3–6 сутки** — серозный менингит, острые вялые параличи, ромбэнцефалит

Паротитный менингит развивается чаще **на 3–6 день**, реже **до 30 дня** после припухания слюнных желёз; у 4% — без клинических признаков их воспаления. Острый период — 5–7 дней, санация ликвора — к 18–20 дню.

Часто встречается неврит VIII пары черепных нервов: системное головокружение, рвота, нистагм; движения глаз и головы усиливают головокружение, дети стараются лежать неподвижно. Вестибулярные нарушения держатся несколько дней и постепенно проходят. Паротитный менингит может быть поствакцинальным осложнением.

1. **герпетический менингит** — относительно лёгкое течение; горизонтальный нистагм, гиперрефлексия, гиперестезия, светобоязнь; лимфоцитарный плеоцитоз до 200–800 клеток в 1 мкл
2. **ветряночный менингит** — на 5–7 сутки от появления сыпи; у трети — анизорефлексия и атаксия; выздоровление на 3–4 неделе
3. **при опоясывающем герпесе** — выраженный общеинфекционный синдром, ганглиониты и ганглионевриты, лёгкие менингеальные симптомы
4. **лимфоцитарный хориоменингит** — у детей раннего возраста возможны судороги, нарушение сознания, септический шок; плеоцитоз 100–1500 клеток; у 30–50% — изменения глазного дна
5. **клещевой энцефалит** — одно- или двухволновое течение, мелкоразмашистый нистагм, статическая атаксия; санация на 3–4 неделе, возможна хронизация (3%)
6. **коревой, аденовирусный, гриппозный** — без значимых клинических особенностей

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз ВМ устанавливается на основании

1. физикального обследования: общемозговые, и/или очаговые, и/или менингеальные симптомы после инкубационного периода **2–30 дней**;
2. лабораторных исследований: специфические антитела IgM и нарастающий титр IgG в крови и ЦСЖ к подозреваемым вирусам и/или вирусная РНК или ДНК методом ПЦР в крови и ЦСЖ;
3. эпидемиологического анамнеза: контакты с больными, пребывание в эндемичных регионах, контакты с грызунами, присасывание клеща, употребление сырого козьего молока, вакцинация.

3.2 Физикальное обследование

При осмотре обращают внимание

1. общеинфекционная симптоматика: интоксикация, лихорадка;
2. общемозговая симптоматика: головная боль, тошнота, рвота, светобоязнь, кожная гиперестезия;
3. менингеальные симптомы;
4. очаговая неврологическая симптоматика.

1. **инфекционист** — всем при подозрении на ВМ
2. **офтальмолог** — перед спинномозговой пункцией: застойные явления на глазном дне — противопоказание к пункции
3. **невролог** — всем с ВМ, оценка сознания по шкале комы Глазго, менингеальных и очаговых симптомов

3.3 Лабораторные исследования

Всем пациентам выполняются общий (клинический) анализ крови и спинномозговая пункция **в течение первых суток** при отсутствии противопоказаний.

Исследование ЦСЖ

1. микроскопия, цитоз;
2. глюкоза, белок, лактат;
3. натрий, хлориды.

Для ВМ характерен умеренный плеоцитоз (до 1000 клеток в 1 мкл) с преобладанием мононуклеаров и незначительное повышение белка.

При подозрении на отёк головного мозга и других противопоказаниях спинномозговая пункция не проводится до стабилизации состояния.

Повторная спинномозговая пункция проводится **на 7–10 сутки**.

ПЦР крови — всем пациентам

1. ДНК вирусов простого герпеса 1 и 2 типов, варицелла зостер;
2. ДНК цитомегаловируса, вируса Эпштейна — Барр, герпеса 6 и 7 типов;
3. по эпидемическим показаниям — ДНК боррелий и антиген вируса клещевого энцефалита.

В ЦСЖ методом ПЦР определяются ДНК герпесвирусов, РНК неполиомиелитных энтеровирусов, ДНК парвовируса B19, РНК вируса краснухи, ДНК боррелий. Отрицательный результат при первом обследовании заболевание не исключает.

Одновременно с ПЦР методом ИФА определяются антитела к вирусам, способным вызвать ВМ, — в остром периоде и в динамике.

На острую инфекцию указывают IgM и/или нарастание титра IgG в 2–4 раза и более в парных сыворотках; однократное выявление IgG острой инфекцией не считается.

Серологическое исследование ликвора проводится в остром периоде и в динамике; антитела в ЦСЖ появляются позже, чем в крови, почти всегда к 10 суткам.

При подозрении на васкулит исследуется система гемостаза: коагулограмма, D-димер.

Для дифференциальной диагностики с бактериальным менингитом и безопасности терапии выполняются биохимический анализ крови и общий анализ мочи.

При подозрении на бактериальные осложнения или сепсис исследуются С-реактивный белок и прокальцитонин.

3.4 Инструментальные исследования

При тяжёлом течении в остром периоде регистрируются акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП) — для выявления нарушения проведения на стволовом уровне и при подозрении на нейросенсорную тугоухость как осложнение тяжёлого ВМ. АСВП позволяют диагностировать менингоэнцефалит и синдром внутричерепной гипертензии.

1. **УЗИ головного мозга** — всем с нарушением сознания — отёк, смещение срединных структур
2. **УЗИ глазного яблока** — при подозрении на внутричерепную гипертензию — толщина зрительного нерва
3. **ЭЭГ** — при нарушении сознания и судорогах
4. **зрительные вызванные потенциалы** — при тяжёлом течении с признаками внутричерепной гипертензии
5. **КТ головного мозга с контрастированием** — при подозрении на паранеопластический синдром, объёмное образование
6. **МРТ головного мозга с контрастированием** — при очаговой симптоматике — менингоэнцефалит, осложнения

При внутричерепной гипертензии, судорогах и нарушении сознания показана консультация анестезиолога-реаниматолога для решения о переводе в ОРИТ.

3.5 Дифференциальная диагностика

ВМ дифференцируют с инфекционными и неинфекционными заболеваниями ЦНС, в том числе с онкопатологией; решающее значение имеет отсутствие воспалительных изменений в ЦСЖ у неинфекционных заболеваний, сезонность и указание на укусы клещей.

С бактериальным гнойным менингитом дифференцируют при смешанном или нейтрофильном плеоцитозе; дополнительно определяют нейроспецифические белки: для ВМ характерны нейронспецифическая енолаза **до 3,0 нг/мл**, глиальный фибриллярный кислый белок **до 1,0 нг/мл**, белок S100 **до 200 нг/л**.

---

4. Лечение

При подозрении на ВМ всем пациентам показана экстренная госпитализация в стационар с инфекционными койками и ОРИТ из-за возможного внезапного утяжеления состояния. Лечение включает этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию; хирургическое лечение не проводится.

4.1 Этиотропное лечение

Детям **старше 4 лет** назначается интерферон альфа-2b или иммуностимуляторы; противовирусные препараты системного действия показаны всем пациентам — как можно раньше.

1. **герпесвирусная этиология** — ацикловир по инструкции
2. **клещевой энцефалит** — #рибавирин 10 мг/кг/сут в 2–3 приёма **14 суток**, контроль ЭКГ
3. **дети старше 7 лет, в том числе энтеровирусный менингит** — #тилорон: 7–12 лет — 60 мг/сут, старше 12 лет — 125 мг/сут однократно 7 дней, затем через день 5 дней

При невозможности терапии #рибавирином назначают другие иммуностимуляторы: #меглюмина акридонацетат детям **старше 7 лет** — 10 мг/кг 1 раз в день перед едой в 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 день. После курса при клещевом энцефалите — технологически обработанные антитела к гамма-интерферону.

Антибактериальные препараты системного действия назначаются только при вторичных бактериальных осложнениях (стартово — цефотаксим, цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам); при отсутствии очагов бактериальной инфекции не показаны.

4.2 Патогенетическая терапия

1. **внутричерепная гипертензия и отёк мозга** — консультация анестезиолога-реаниматолога
2. **отёк головного мозга** — кортикостероиды системного действия, предпочтительно дексаметазон
3. **синдром внутричерепной гипертензии** — ангиопротекторы: #эсцина лизинат 0,15 мг/кг 2 раза в сутки внутривенно капельно, курс от 10 дней
4. **нейропротекция с острого периода** — #инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота 0,6 мл/кг (максимум 10 мл) внутривенно 1 раз в день **до 10 дней**; левокарнитин
5. **крайне тяжёлое течение** — иммуноглобулин человека нормальный внутривенно

4.3 Симптоматическая терапия

При температуре **выше 38,5 °C** и/или плеоцитозе **более 300 клеток в 1 мкл** применяют ибупрофен (детям **старше 3 месяцев**) или другие анальгетики и антипиретики — парацетамол (детям **старше 1 месяца**).

При судорогах применяют противоэпилептические препараты; препарат выбора — вальпроевая кислота, показанием служит даже однократный приступ. Одновременно с меропенемом вальпроевая кислота не назначается: он снижает её концентрацию.

Для нейропротекции и купирования экстрапирамидных нарушений **с 5–7 дня** назначается пирацетам, а также #деанола ацеглумат, гопантеновая кислота, #полипептиды коры головного мозга скота; при тяжёлых формах **с 3–5 дня** — поливитамины (детям старше 1 года).

4.4 Медицинская реабилитация

В раннем восстановительном периоде показана консультация врача по лечебной физкультуре; при стихании острого процесса — лечебная физкультура в зависимости от тяжести.

Принципы реабилитации

1. начало в периоде ранней реконвалесценции;
2. последовательность и преемственность этапов;
3. комплексный характер с участием разных специалистов;
4. адекватность нагрузок адаптационным возможностям, постоянный контроль эффективности.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Рекомендуется вакцинация детей против вирусных инфекций, которые могут осложняться ВМ, по Национальному календарю профилактических прививок; плановые схемы имеют приоритет над экстренными.

1. учёт контактов с инфекционными больными;
2. личная гигиена и термическая обработка продуктов;
3. предупреждение контактов с переносчиками.

5.2 Диспансерное наблюдение

Все дети-реконвалесценты ВМ находятся под диспансерным наблюдением; кратность и сроки определяет лечащий врач. Снятие с учёта — при полном восстановлении работоспособности, удовлетворительном самочувствии, отсутствии клинических признаков и очаговой симптоматики, сероконверсии.

5.3 Показания к госпитализации

При подозрении на ВМ показана экстренная госпитализация вне зависимости от этиологии, формы и тяжести — в стационар с ОРИТ; при нарастающей внутричерепной гипертензии и отёке мозга транспортировка — бригадой анестезиологии-реанимации.

Критерии выписки

1. нормализация общего состояния;
2. отсутствие интоксикации;
3. значительное снижение или исчезновение неврологического дефицита.

Лабораторные критерии выздоровления

1. вирусная РНК, ДНК или антиген методом ПЦР не обнаруживаются;
2. отсутствие IgM **не позднее 3 месяцев** от начала или их снижение после терапии;
3. отсутствие нарастания титра IgG через 3 и более месяцев, нормализация состава ЦСЖ.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Вирусные менингиты у детей»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 24.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	995_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Ассоциация врачей инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.

Клинические рекомендации

Воспалительные заболевания челюстей у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K10.2** — Воспалительные заболевания челюстей **M86** — Остеомиелит
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/997_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Хронический остеомиелит челюсти — гнойное деструктивное или пролиферативное воспаление кости **более 4 недель** с образованием секвестров или без тенденции к выздоровлению. Различают первично-хронический (негнойный), вторично-хронический (гнойный) остеомиелит и продуктивный периостит.
- Диагноз первично-хронического остеомиелита устанавливают при наличии 2 больших или 1 большого и 3 малых критериев. Для исключения сарком и фиброзно-костных поражений выполняется биопсия.
- При обострении вторично-хронического остеомиелита антибиотик широкого спектра назначают эмпирически с первых часов госпитализации, эффект оценивают **через 2–3 дня** и корректируют терапию по результатам посева. Поднадкостничный абсцесс вскрывают внутриротовым доступом, флегмону вскрывают и дренируют наружным доступом.
- Основным методом лечения вторично-хронического остеомиелита является хирургический: секвестрэктомия или резекция челюсти, которые выполняют только после формирования секвестральной полости и полного отграничения секвестра.
- Показания к экстренной госпитализации:
  1. обострение при суб- или декомпенсированных сопутствующих заболеваниях, гиперергическом течении, опухолях, иммунодефиците;
  2. невозможность операции под местной анестезией;
  3. отсутствие стоматолога-хирурга.

  Плановая госпитализация показана при хроническом остеомиелите со сформированным секвестром, а также при затяжном, торпидном или прогрессирующем течении.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Остеомиелит — воспалительное состояние костной ткани различной природы, которое начинается с медуллярной полости, быстро распространяется по системе гаверсовых каналов, вовлекая в воспаление надкостницу и прилегающие мягкие ткани.

Периостит — воспалительное заболевание, вовлекающее надкостницу альвеолярного отростка и тела челюсти из одонтогенного или неодонтогенного очага.

Секвестр — отграниченный воспалительно-некротический очаг костной ткани, располагающийся более или менее свободно и не подвергающийся аутолизу.

Зубоальвеолярный сегмент — условная единица объёма альвеолярной части челюсти для оценки распространённости воспаления; верхняя граница сегментов верхней челюсти — дно полости носа и верхнечелюстных пазух.

Симптом Венсана — снижение чувствительности кожи над поражённым участком и (или) нижней губы.

Формы хронического воспаления челюстей

1. **первично-хронический остеомиелит (негнойный)**: фиброзно-костное продуктивное заболевание без выявленного триггера, без гноя, свищей и секвестров, с упорно-рецидивирующим течением и избыточным образованием кости;
2. **вторично-хронический остеомиелит**: гнойное деструктивное или пролиферативное воспаление **более 4 недель**, связанное с одонтогенной инфекцией, инородными телами, травмой, пороком развития кости или системными заболеваниями;
3. **хронический периостит челюсти**: хронический одонтогенный процесс с вовлечением надкостницы, который может выходить за пределы пародонта одного зубоальвеолярного сегмента;
4. **хронический рецидивирующий мультифокальный остеомиелит**: неинфекционное многоочаговое литическое поражение костей; у взрослых ему соответствует синдром SAPHO (синовит, акне, пустулёз, гиперостоз, остеит).

2.2 Этиология и эпидемиология

Первично-хронический остеомиелит — небактериальное хроническое воспалительное заболевание неизвестной этиологии, которое может быть связано с другими состояниями, включая аутоиммунные заболевания и синдромы. В настоящее время преобладает генетическая теория; в большинстве случаев посевы удалённых фрагментов челюстей стерильны.

Вторично-хронический остеомиелит возникает в результате внедрения микроорганизмов в челюсть при травме или одонтогенной инфекции, чаще всего стоматологического происхождения (заболевание пульпы, удаление зуба, инородные тела). На неспорообразующие анаэробы приходится 65–75% микрофлоры.

Продуктивный периостит чаще всего развивается как осложнение хронического периодонтита (74,6%), поражение при этом обычно располагается в области первого коренного зуба.

Хронические негнойные формы встречаются с частотой 1–2 на 1 000 000; первично-хронический остеомиелит у девочек в 4 раза чаще, средний возраст 9–10,8 года. Продуктивный периостит чаще у мальчиков, дебют в 8,8–11 лет. Чаще поражается нижняя челюсть.

2.3 Классификация

По течению

1. первично-хронический: ювенильный продуктивный, синдром-ассоциированный (SAPHO, синдром Маджида, DIRA, PAPA);
2. вторично-хронический: одонтогенный, неодонтогенный (неонатальный, травматический, от инородного тела, при мальформации сосудов);
3. продуктивный периостит: простой, оссифицирующий (остеомиелит Гарре), посттравматический.

По этиологии

1. гнойный: специфический (туберкулёзный, актиномикозный), неспецифический (бактериальный, грибковый);
2. негнойный: остеорадионекроз, медикаментозный, аутоиммунный.

По локализации

1. верхняя или нижняя челюсть;
2. локальный: зубоальвеолярный сегмент, альвеолярная часть, базис, ветвь;
3. распространённый: тотальный, субтотальный.

Острый остеомиелит отличается от хронического длительностью **менее 4 недель** от появления симптомов.

2.4 Клиническая картина

Первично-хронический остеомиелит протекает с обострениями (от нескольких дней до недель) и ремиссиями (от нескольких месяцев до нескольких лет). Поражение челюсти чаще наблюдается у девочек, как правило, унифокально; возраст дебюта около 10 лет (4–14 лет).

Симптомы при поражении нижней челюсти

1. боль, часто усиливающаяся ночью, с лихорадкой или без;
2. ограничение открывания рта, отёк;
3. регионарная лимфаденопатия;
4. парестезия над очагом и (или) нижней губы.

Гной, свищи и секвестры отсутствуют, что отличает его от острого и вторично-хронического остеомиелита. При тяжёлом течении исключают злокачественные новообразования, прежде всего острый лимфобластный лейкоз.

Около 25% пациентов имеют кожные (псориаз, ладонно-подошвенный пустулёз, акне) и кишечные заболевания (болезнь Крона, язвенный колит); при поражении челюсти, ключицы, грудины возможны бессимптомные очаги в скелете.

Вторично-хронический остеомиелит характеризуется гноем, свищами и секвестрами, течёт с обострениями.

Местные проявления

1. свищевые ходы до кости с гноем или грануляциями;
2. абсцессы и флегмоны при обострении;
3. ограничение открывания рта при поражении угла и ветви нижней челюсти;
4. подвижность зубов в очаге.

Продуктивный периостит проявляется односторонним безболезненным плотным утолщением задних двух третей нижней челюсти с умеренной асимметрией лица, без признаков воспаления кожи и слизистой оболочки; толщина нароста до 2–3 см. Иногда возможны свищ и лимфаденопатия.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза первично-хронического остеомиелита

Критерии диагноза первично-хронического остеомиелита

Большие критерии	Малые критерии
рентгенологически подтверждённые остеолитические и остеосклеротические очаги	хорошее общее состояние и нормальная лейкоцитарная формула
множественные очаги поражения	СОЭ и С-реактивный белок незначительно повышены
псориаз или ладонно-подошвенный пустулёз	длительность заболевания более 6 месяцев
стерильная биопсия с признаками воспаления и (или) фиброза, склероза	гиперостоз

Большие критерии	Малые критерии
—	связь с другими аутоиммунными заболеваниями; аутоиммунные и аутовоспалительные заболевания у родственников I и II линии

Для постановки диагноза необходимы 2 больших или 1 большой и 3 малых критерия.

3.2 Жалобы и анамнез

Сбор жалоб и анамнеза проводит челюстно-лицевой хирург или стоматолог-хирург.

Основные жалобы

1. боль в зубе или челюсти, иррадиация по ветвям тройничного нерва;
2. подвижность зубов, отёк мягких тканей;
3. парестезия нижней губы и подбородка;
4. ограничение открывания рта, боль при глотании, жевании, движениях языка;
5. свищи, деформация челюстей;
6. симптомы интоксикации.

Уточняют связь с заболеванием или удалением зуба, переохлаждением, простудой, перенапряжением; динамику и проведённое лечение.

3.3 Осмотр полости рта и челюстно-лицевой области

Оценка общего состояния: визуальный осмотр, термометрия, пальпация костной системы, осмотр полости рта и челюстно-лицевой области при обострении.

Клиническая оценка мягких тканей, регионарных лимфоузлов и полости рта: пальпация, перкуссия, степень открывания рта и подвижности нижней челюсти. Определяется изменение конфигурации лица за счёт инфильтрации и периостального утолщения; кожа над утолщением не изменена.

3.4 Биопсия

Биопсия из очага выполняется для дифференциальной диагностики с фиброзно-костными поражениями и остеосаркомами, поскольку на ранних этапах их клиническая картина сходна с хроническим остеомиелитом.

Материал, полученный при операции, направляют на патологоанатомическое исследование для дифференциальной диагностики с невоспалительными поражениями и специфическим воспалением.

3.5 Лабораторные исследования: анализы крови и посев

Общий анализ крови позволяет оценить выраженность воспаления. При обострении вторично-хронического остеомиелита выявляется лейкоцитоз более $10 \cdot 10^9$/л, нейтрофилы до 70–80%; СОЭ повышается до 40 мм/ч при гиперергии или остаётся в норме при гипоергии.

Уровень С-реактивного белка отражает динамику воспаления и необходимость коррекции терапии; при хронических формах его повышение умеренное и неспецифичное.

Всем пациентам с подозрением на воспалительное заболевание челюсти выполняется посев гноя, отделяемого свищей и ран с определением чувствительности. Материал биопсии и вскрытия абсцесса обязательно направляют на посев.

3.6 Компьютерная томография челюстно-лицевой области

КТ выполняется для определения распространённости и типа процесса и планирования лечения, в том числе при обострении.

Диагностические признаки

1. первично-хронический остеомиелит: на ранней стадии изменений может не быть, позже выявляется смешанная картина склероза и остеолиза, периостальная реакция, «кость на кости»; секвестры крайне редки;
2. вторично-хронический остеомиелит: очаги деструкции с секвестрами и участками остеосклероза; секвестр отграничивается **на 4–6-й неделе** на верхней челюсти и **на 6–8-й неделе** на нижней;
3. продуктивный периостит: слоистые периостальные наслоения по типу «луковой шелухи» над компактной костью в области причинного зуба.

3.7 УЗИ мягких тканей и лимфоузлов шеи

УЗИ мягких тканей, костей челюстно-лицевой области и лимфатических узлов шеи применяют для оценки гнойного процесса и дифференциальной диагностики с абсцессами, артритами и опухолями.

---

4. Лечение

Основные компоненты лечения

1. хирургическое лечение: санация очага, удаление причинного зуба, вскрытие и дренирование абсцесса;
2. общая и местная противомикробная терапия;
3. патогенетическое и симптоматическое лечение.

Лечение первично-хронического остеомиелита

1. первая линия: санация полости рта, НПВП;
2. вторая линия: плоскостная резекция очага, антибиотики, системные глюкокортикоиды, бисфосфонаты, ингибиторы ФНО-альфа или интерлейкинов.

4.1 Антибактериальная терапия

При выявлении инфекционной причины проводится рациональная антибактериальная терапия по результатам посева; шаблонное применение антибиотиков недопустимо. При первично-хроническом остеомиелите антибиотики неэффективны.

При обострении вторично-хронического остеомиелита антибиотик широкого спектра начинают эмпирически с первых часов в стационаре, эффект оценивают **через 2–3 дня**, затем корректируют по посеву. Средняя длительность терапии составляет **5–10 дней**.

Критерии достаточности антибактериальной терапии

1. стойкая нормализация температуры;
2. положительная динамика основных симптомов;
3. нет признаков системной воспалительной реакции;
4. нормализация лейкоцитов, формулы, СОЭ, СРБ;
5. отрицательная гемокультура;
6. нормализация функции ЖКТ.

Сохранение только одного признака бактериальной инфекции (лихорадка или лейкоцитоз), а также гранулирующая рана не являются абсолютным показанием к продолжению антибактериальной терапии.

При стабилизации общего состояния, переходе местного гнойного процесса во II фазу, положительной динамике или нормализации лабораторных показателей системные антибиотики отменяют, и в дальнейшем акцент переносят на местное применение антисептиков.

При отсутствии стойкого ответа на адекватную терапию **в течение 1–3 дней** необходимо дополнительное обследование (УЗИ, КТ, посевы) для поиска осложнений и вторичного очага.

При отягощённом соматическом статусе продолжительность антибактериальной терапии увеличивают; при выделении S. aureus или P. aeruginosa с бактериемией её проводят **не менее 14 суток**.

Другие показания к продлению антибактериальной терапии

1. воспаление в труднодоступных локусах: клапаны сердца, ЦНС, кости, предстательная железа;
2. сохраняющаяся нейтропения;
3. невозможность одномоментной хирургической санации и дренирования первичного или вторичных очагов;
4. воспаление, вызванное поли- и панрезистентными микроорганизмами.

4.2 Дополнительная терапия

При обострении проводится дезинтоксикационная инфузионная терапия сбалансированными растворами.

Гипербарическую оксигенацию допустимо применять только как вспомогательный метод из-за высокой частоты рецидивов и опасных осложнений.

При хроническом небактериальном остеомиелите для купирования боли применяют НПВП (эффективны у 40–80% детей): #метамизол натрия, парацетамол, ибупрофен, #кетопрофен.

При первично-хроническом остеомиелите системные глюкокортикоиды назначают при неэффективности НПВП, а также при рецидивирующем или тяжёлом течении.

1. преднизолон: 2 мг/кг в сутки внутрь **1 неделю** с последующим снижением дозы на 25% каждые 5 дней.

При упорно рецидивирующем течении возможно применение внутривенных форм.

Для достижения стойкой ремиссии хронического остеомиелита применяют препараты, влияющие на минерализацию кости (бисфосфонаты).

1. #памидроновая кислота: 1 мг/кг (максимум 60 мг) ежемесячно или 1 мг/кг 3 дня подряд каждые 3 месяца.

4.3 Хирургическое лечение

Принципы хирургического лечения

1. вскрытие гнойного очага и удаление причинного зуба;
2. выбор обезболивания совместно с анестезиологом;
3. кратчайший доступ к очагу с наименьшим риском повреждения сосудов и нервов и лучшим оттоком.

При первично-хроническом остеомиелите выполняют биопсию кости в объёме декортикации очага, что улучшает доступ препаратов в очаг.

При продуктивном периостите устраняют источник инфекции (удаление или лечение зуба, вскрытие абсцесса) или травмы, иссекают изменённую надкостницу и избыточную кость.

При обострении поднадкостничный абсцесс вскрывают внутриротовым доступом (периостотомия); при флегмоне или свище выполняют вскрытие и дренирование наружным доступом.

При вторично-хроническом остеомиелите выполняют секвестрэктомию или резекцию челюсти в пределах неизменённой кости. Операцию проводят только после формирования секвестральной полости и полного отграничения секвестра (по данным КТ, на верхней челюсти **на 4–6-й неделе**, на нижней **на 6–8-й неделе**).

На верхней челюсти используют внутриротовой доступ. При осложнении верхнечелюстным синуситом или секвестрации стенок пазухи секвестрэктомию выполняют по типу радикальной операции на верхнечелюстной пазухе (по Колдуэллу — Люку).

При рарефицирующем периостите и гиперпластической форме хронического остеомиелита показано оперативное вмешательство: вскрытие и дренирование флегмоны или абсцесса в костной ткани, некрэктомия и выскабливание грануляций.

Гнойный очаг дренируют (дренаж Пенроуза, силиконовые дренажи) и проводят местное лечение раны по фазам: в I фазе применяют антисептики, во II фазе средства, стимулирующие репарацию.

Антисептики в I фазе раневого процесса (орошения, инстилляции, внутрикостный лаваж ежедневно)

1. хлоргексидин: 0,02% и 0,05% раствор;
2. бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний: 0,01% раствор;
3. #повидон-йод: 10% раствор в разведении в 10 или 100 раз, 7,5% раствор.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация

1. обострение при суб- или декомпенсированных сопутствующих заболеваниях, гиперергическом течении, опухолях, иммунодефиците;
2. невозможность операции под местной анестезией (поведение ребёнка, сопутствующая патология, аллергия на анестетики);
3. отсутствие стоматолога-хирурга.

Плановая госпитализация

1. хронический остеомиелит со сформированным секвестром;
2. затяжное, торпидное или прогрессирующее течение с длительным формированием секвестров.

Пациента выписывают при неосложнённом раннем послеоперационном периоде, удовлетворительном состоянии, контролируемой боли и возможности продолжить антибиотики амбулаторно под наблюдением челюстно-лицевого хирурга.

5.2 Профилактика и реабилитация

Основой профилактики является санация полости рта.

1. осмотр стоматолога-терапевта и стоматолога-хирурга: не реже 1 раза в год;
2. профессиональная гигиена: не реже 1 раза в 6 месяцев;
3. осложнённый кариес: своевременное эндодонтическое лечение.

Физиотерапию (электрофорез, ультразвук, парафин) применяют после адекватного хирургического лечения, ЛФК — в период ремиссии.

Факторы риска рецидива

1. возраст **6–12 лет** (смешанный прикус);
2. лейкоцитоз более $15 \cdot 10^9$/л и температура выше 39 °C при поступлении;
3. MRSA-инфекция (риск выше в 4 раза);
4. предшествующее введение антибиотиков;
5. диабет.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Воспалительные заболевания челюстей»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 24.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	997_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых расхождений в тексте рекомендации при сверке не найдено.

Клинические рекомендации

Врождённая цитомегаловирусная инфекция

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**P35.1** — Врожденная цитомегаловирусная инфекция
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 08.07.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии «Российское общество неонатологов»; Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/260_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Врождённая цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) развивается при антенатальной передаче цитомегаловируса (ЦМВ) от матери к плоду и является одной из причин нейросенсорной тугоухости, слепоты, ДЦП и задержки развития.
- Антенатальное заражение подтверждается выявлением ДНК ЦМВ в любом биоматериале (слюна, мазок из ротоглотки, моча, кровь) **в первые 3 недели жизни**. Антитела IgG у новорождённого диагноз не подтверждают.
- Каждому ребёнку с любой формой врождённой ЦМВИ, независимо от аудиологического скрининга, показано исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов **до 3 месяцев жизни**.
- Отрицательный результат скрининга слуха методом отоакустической эмиссии является показанием к обследованию новорождённого на ЦМВИ.
- При среднетяжёлой и тяжёлой форме назначается #валганцикловир 16 мг/кг 2 раза в сутки внутрь в течение **6 месяцев**. При изолированном снижении слуха тот же препарат назначают на **6 недель**; лечение начинают как можно раньше.
- Всем детям с врождённой ЦМВИ показано наблюдение сурдолога-оториноларинголога:
  1. **каждые 3 месяца** на первом году жизни;
  2. **каждые 6 месяцев** до 3 лет;
  3. **ежегодно до 18 лет**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Врождённая цитомегаловирусная инфекция — инфекционное заболевание, развившееся в результате антенатальной передачи возбудителя от матери к плоду при первичном заражении беременной, реактивации ранее приобретённой инфекции во время беременности или заражении серопозитивной беременной другим штаммом цитомегаловируса.

Цитомегаловирусная инфекция — распространённая вирусная инфекция, вызываемая цитомегаловирусом (Human Cytomegalovirus), с проявлениями от бессимптомного течения до тяжёлых генерализованных форм с поражением внутренних органов и ЦНС (при иммунодефиците и внутриутробном поражении плода).

2.2 Этиология и патогенез

Возбудитель — герпесвирус человека 5 типа. При первичном заражении беременной транзиторная виремия ведёт к поражению плаценты и передаче вируса плоду; вирус реплицируется в эндотелии и поражает почки, печень, миокард, головной мозг. Тяжесть поражения тем выше, чем меньше гестационный возраст при заражении.

Частота симптоматической формы и отдалённых последствий, в том числе нейросенсорной тугоухости, не зависит от того, было ли заражение беременной первичным или вторичным (реактивация, суперинфекция новым штаммом).

Врождённая ЦМВИ встречается у 0,5–2,5% живорождённых (в среднем около 1%). Клинические формы составляют 10–70%, из них у 20–60% детей развиваются тяжёлые необратимые последствия (нарушения слуха, эпилепсия, задержка развития, атрофия зрительного нерва). При субклинической форме (30–90% инфицированных) отдалённые последствия развиваются у 10–20%.

Вероятность передачи вируса плоду при первичном заражении растёт с 30% в I триместре до 72% в III, но наиболее тяжёлые поражения возникают при заражении в I триместре. При реактивации передача составляет около 1,5–2%, при повторном заражении — до 20%; вторичная инфекция обусловливает 50–80% всех случаев внутриутробного инфицирования.

2.3 Классификация

Формы врождённой ЦМВИ

1. клиническая форма:
    1. среднетяжёлая и тяжёлая;
    2. лёгкая;
    3. изолированное снижение слуха;
2. субклиническая форма;
3. осложнения.

Среднетяжёлая и тяжёлая форма

1. множественные проявления: тромбоцитопения, петехии, гепато- и спленомегалия, малый размер к сроку гестации, гепатит;
2. менингоэнцефалит, в том числе судороги;
3. хориоретинит;
4. микроцефалия;
5. характерные изменения головного мозга при НСГ, КТ или МРТ: кальцификаты, перивентрикулярные кисты, вентрикулодилатация, аномалии белого вещества, атрофия коры, гипоплазия мозжечка, лентикулостриарная васкулопатия.

Лёгкая форма: 1–2 изолированных клинически незначимых или транзиторных проявления: невыраженная гепатомегалия, однократное снижение тромбоцитов или повышение АЛТ.

Изолированное снижение слуха: клинических и лабораторных признаков заболевания нет, кроме снижения слуха **на 20 дБ и более**. У детей, не прошедших скрининг слуха методом отоакустической эмиссии, необходим дифференциальный диагноз между врождённой ЦМВИ и другими причинами тугоухости.

Субклиническая форма: ЦМВ в крови, моче или слюне при отсутствии клинически значимых признаков заболевания и изменений при обследовании.

«Поздние» проявления у 10–20% детей в первые 3–6 месяцев

1. задержка психомоторного развития;
2. нейросенсорная тугоухость;
3. хориоретинит.

Дети с субклинической формой требуют динамического наблюдения.

2.4 Клиническая картина

Клинические проявления

1. малый размер для гестационного срока, микроцефалия (менее 10-го перцентиля);
2. петехии, пурпура, сыпь по типу «черничного кекса»;
3. ЦМВ-ассоциированная желтуха с первых суток, дольше физиологической;
4. гепатомегалия, спленомегалия;
5. неврологические симптомы вплоть до комы, судороги;
6. нейросенсорная тугоухость, вплоть до глухоты, одно- или двусторонняя;
7. хориоретинит, ретинальные кровоизлияния, атрофия зрительного нерва, катаракта, косоглазие.

Лабораторные и инструментальные изменения

1. анемия, тромбоцитопения (менее 100 000 кл/мкл), лейкопения, нейтропения (менее 1000 кл/мкл);
2. повышение трансаминаз, конъюгированная гипербилирубинемия;
3. белок и плеоцитоз в ликворе, ДНК ЦМВ в ликворе;
4. кальцификаты (чаще перивентрикулярные), кисты, вентрикулодилатация, лентикулостриарная васкулопатия при НСГ и КТ; МРТ лучше выявляет нарушения миграции нейронов и задержку миелинизации.

Снижение слуха вплоть до глухоты может прогрессировать несколько лет: около 40% нарушений слуха формируется после неонатального периода у детей с нормальным скринингом. Поэтому мониторинг слуха необходим при любой форме, в том числе субклинической; сроки наблюдения сурдолога приведены в разделе «Диспансерное наблюдение».

Тугоухость при врождённой ЦМВИ сопровождается поражением вестибулярного аппарата (до 92,3%), нередко прогрессирующим. При латентной форме нарушения вестибулярной функции выявляются почти у половины детей младшего школьного возраста; изолированные нарушения равновесия при сохранном слухе значительно недооцениваются.

При клинически выраженной форме отдалённые последствия включают задержку психомоторного развития (50%), нейросенсорную глухоту (50%) или двустороннее снижение слуха (37%), нарушение восприятия речи при сохранном слухе (27%), нарушения зрения (22–58%). При субклинической форме значительное ухудшение слуха развивается в 5–23% случаев.

Летальность при тяжёлой форме достигает 5–7%. При микроцефалии инвалидность развивается более чем в 50% случаев.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз с указанием формы устанавливается на основании

1. анамнеза матери;
2. клинических проявлений при физикальном обследовании;
3. лабораторных исследований;
4. инструментальных исследований.

Антенатальное заражение доказывает выявление ДНК ЦМВ в любом биоматериале **в первые 3 недели жизни**. Клиническая форма устанавливается при характерных признаках, этиология которых подтверждена ПЦР, субклиническая форма — при ДНК ЦМВ без характерных признаков.

Диагноз не может быть установлен по антителам IgG к ЦМВ у новорождённого; убедительных данных о значимости авидности IgG нет.

Показания к обследованию новорождённого на ЦМВИ

1. гепатоспленомегалия, петехии, пурпура, сыпь по типу «черничного кекса», затяжная желтуха, микроцефалия;
2. судороги неясной этиологии;
3. тромбоцитопения неясной этиологии, конъюгированная гипербилирубинемия, затяжная желтуха с повышением трансаминаз;
4. кальцификаты, вентрикуломегалия и другие изменения при нейровизуализации;
5. хориоретинит, врождённая катаракта;
6. отрицательный результат скрининга слуха методом отоакустической эмиссии;
7. признаки инфекции при антенатальном УЗИ или МРТ плода;
8. сероконверсия или симптомы, характерные для ЦМВИ, у матери во время беременности;
9. недоношенность **менее 32 недель** или масса тела **менее 1500 г**.

3.2 Жалобы и анамнез

У матери уточняют подозрение на ЦМВИ или подтверждённую ЦМВИ во время беременности, в том числе перенесённое ОРВИ-подобное заболевание или лихорадку неустановленной этиологии.

Специфичными УЗ-признаками внутриутробной ЦМВИ у плода являются кальцификаты в головном мозге, вентрикуломегалия, микроцефалия, гепатоспленомегалия.

Обследование недоношенных с гестационным возрастом **32 недели и менее** или массой тела при рождении **1500 г и менее** необходимо для последующей дифференциальной диагностики с постнатальной ЦМВИ.

Признаки ЦМВ-поражения плаценты или антигены ЦМВ при исследовании последа являются показанием к обследованию новорождённого.

Лабораторные и (или) инструментальные признаки, характерные для ЦМВИ, являются показанием к обследованию на ЦМВИ.

3.3 Визуальный осмотр

Новорождённому с подозрением на врождённую ЦМВИ показан визуальный осмотр.

Чаще всего встречается микроцефалия, которая является прогностическим признаком неблагоприятного неврологического исхода. Обследуют детей с малым размером к сроку гестации в сочетании с микроцефалией, а не всех с малым размером к сроку гестации.

При клинических признаках врождённой инфекции новорождённому показано обследование на ЦМВИ.

3.4 ПЦР на ДНК цитомегаловируса

Основной метод: количественное определение ДНК ЦМВ методом ПЦР в слюне, мазке со слизистой оболочки ротоглотки, моче, крови **в первые 3 недели жизни**; при недоступности количественного — качественное.

После 3 недель жизни интранатальное или раннее постнатальное заражение исключить нельзя. Наиболее информативны слюна (мазок из ротоглотки) и моча. При грудном вскармливании слюну берут **через 90 минут после кормления**, положительный результат подтверждают ПЦР мочи.

Чувствительность ПЦР мочи 98,8–100% при специфичности 99,1%; соскоба со слизистой оболочки полости рта — 93–100% при низкой положительной прогностической значимости (49–73%).

Рутинное определение ДНК ЦМВ в ликворе не рекомендуется: отрицательный результат не исключает поражения ЦНС.

3.5 Антитела IgM к цитомегаловирусу

При недоступности ПЦР и в сомнительных случаях определяют IgM к ЦМВ в крови (ИФА или ХЛИА). Возможны ложноотрицательные и ложноположительные результаты; кровь берут до введения иммуноглобулинов.

3.6 Общий анализ крови

При подозрении на ЦМВИ выполняется общий анализ крови с лейкоцитарной формулой: выявляются анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения.

3.7 Биохимический анализ крови

При подозрении на ЦМВИ и органные поражения (гепатит, острое повреждение почек) определяют АЛТ, АСТ, свободный и связанный билирубин, креатинин, мочевину.

3.8 Общий анализ мочи

Ребёнку с врождённой ЦМВИ показан общий анализ мочи: возможна протеинурия с тубулоинтерстициальным поражением почек.

3.9 Исследование слуха методом отоакустической эмиссии

Показания: подозрение на врождённую ЦМВИ, подтверждённая ЦМВИ, антенатальные изменения головного мозга при УЗИ или МРТ — для выявления нейросенсорной тугоухости.

Глубоко недоношенным детям исследование проводят после достижения постконцептуального возраста **34 недели**.

3.10 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы

Ребёнку с любой формой врождённой ЦМВИ, независимо от результатов аудиологического скрининга, исследование коротколатентных вызванных потенциалов проводится **до 3 месяцев жизни** для выявления отсроченных нарушений слуха.

3.11 Нейросонография

Показания: подозрение на врождённую ЦМВИ, подтверждённая ЦМВИ, антенатальные изменения головного мозга — выявление поражения ЦНС.

3.12 Магнитно-резонансная томография головного мозга

Показания: подтверждённая врождённая ЦМВИ с неврологическими нарушениями и изменениями головного мозга при НСГ — уточнение объёма и характера поражения ЦНС. МРТ чувствительнее КТ.

3.13 Исследования внутренних органов

При подозрении на органное поражение — УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников, эхокардиография, рентгенография лёгких, обзорная рентгенография брюшной полости в зависимости от вовлечённых органов.

3.14 Консультации специалистов

Новорождённому с подтверждённой ЦМВИ показана консультация офтальмолога; глубоко недоношенным на стационарном этапе — не реже 1 раза в 2 недели.

Новорождённому с подтверждённой ЦМВИ показана консультация невролога; глубоко недоношенным на стационарном этапе — не реже 1 раза в 2 недели.

При нежелательных реакциях на противовирусную терапию показана консультация клинического фармаколога, при тяжёлой нейтропении — гематолога.

4. Лечение

Этиотропное лечение проводится #ганцикловиром и #валганцикловиром (применение вне инструкции). Из-за высокой токсичности их назначают по жизненным показаниям при тяжёлом или среднетяжёлом течении после информированного согласия родителей.

#Валганцикловир менее токсичен и является препаратом выбора. В России он зарегистрирован только в таблетках, суспензия не зарегистрирована. #Ганцикловир применяют при отсутствии энтерального питания или жизнеугрожающем течении.

Отрицательная ПЦР не является целью терапии в остром периоде. Продление или прекращение лечения решает консилиум; при рецидиве после отмены терапию возобновляют.

Препараты миелотоксичны (тяжёлая нейтропения, тромбоцитопения); в эксперименте выявлены канцерогенный эффект и токсическое воздействие на гонады.

4.1 Среднетяжёлая и тяжёлая форма

Противовирусная терапия начинается как можно раньше после установления диагноза для снижения неблагоприятных неврологических исходов, включая нейросенсорную тугоухость.

1. #валганцикловир — 16 мг/кг 2 раза в сутки внутрь, **6 месяцев**;
2. #ганцикловир (нет энтерального питания или жизнеугрожающее течение) — 6 мг/кг 2 раза в сутки внутривенно, по возможности не более **6 недель**.

При нейтропении **менее 500 кл/мкл** препарат временно отменяют на несколько дней или снижают дозу вдвое; на #ганцикловире можно перейти на #валганцикловир. При тромбоцитопении **менее $25 \cdot 10^9$/л** на фоне #ганцикловира препарат временно отменяют.

При клинических формах, требующих противовирусной терапии, дополнительно назначают иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный.

1. доза: 1 мл/кг внутривенно каждые 48 часов до исчезновения клинических симптомов (описаны курсы до 6 введений).

Иммуноглобулин вводят внутривенно непрерывно, строго по инструкции к препарату. Иммуноглобулины нормальные человеческие при активной ЦМВИ существенно менее эффективны, чем антицитомегаловирусный.

4.2 Изолированное снижение слуха

Новорождённому с изолированным снижением слуха показан #валганцикловир 16 мг/кг 2 раза в сутки внутрь **6 недель** для улучшения слуха; лечение начинают как можно раньше.

Улучшение слуха показано при начале терапии **в первые 3 месяца**; при позднем начале улучшения не получено.

В рандомизированном исследовании терапию начинали в возрасте от 1 месяца до 4 лет (медиана 18,7 месяца), курс 6 недель; слух не улучшился.

4.3 Лёгкая и субклиническая формы

При лёгкой форме противовирусная терапия рутинно не рекомендуется; возможна в индивидуальном порядке по решению консилиума и с согласия родителей.

При субклинической форме противовирусная терапия рутинно не рекомендуется: обоснованных данных нет.

4.4 Контроль лечения

Количественная ПЦР крови на ДНК ЦМВ выполняется в начале лечения и **каждые 2–4 недели**. Отсутствие снижения вирусной нагрузки может указывать на резистентность штамма или иммунодефицит.

К концу 6-недельного курса вирус может определяться более чем у 50% пациентов; после отмены препарата вирусная экскреция и виремия могут вернуться к исходному уровню. Нарастание числа копий ЦМВ на фоне лечения, скорее всего, свидетельствует о резистентности вируса, что наблюдается крайне редко.

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой контролируют **еженедельно первые 6 недель**, на 8-й неделе, далее **ежемесячно** весь курс; при терапии колониестимулирующими факторами — ежедневно до нейтрофилов более 1000 кл/мкл.

Биохимический анализ крови с натрием и калием выполняется **ежемесячно** для своевременной коррекции дозы.

4.5 Сопутствующая терапия

При тяжёлой нейтропении (**менее 500 кл/мкл**), не купирующейся временной отменой противовирусного препарата, после консультации гематолога назначают филграстим.

1. доза: 5 мкг/кг в сутки подкожно или внутривенно, при неэффективности до 10 мкг/кг в сутки;
2. длительность: как правило, 1–3 дня до нейтрофилов 1000 кл/мкл и более.

Прирост нейтрофилов, как правило, наблюдается через **24–48 часов**.

Трансфузия лейкоредуцированного концентрата тромбоцитов 10–15 мл/кг показана при тромбоцитопении без кровотечения как до начала, так и на фоне противовирусной терапии:

1. новорождённые: **менее 25 000 кл/мкл**;
2. дети **старше 1 месяца**: **менее 20 000 кл/мкл**.

Патогенетическую и симптоматическую терапию проводят по ведущим синдромам: назначают гемостатическую, противосудорожную, седативную, кардиотоническую, инфузионную терапию.

Вскармливание материнским молоком при любой форме врождённой ЦМВИ не прекращают.

Медицинская реабилитация проводится по органным поражениям с участием невролога, сурдолога-оториноларинголога и офтальмолога.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Всем детям с любой формой врождённой ЦМВИ показано наблюдение сурдолога-оториноларинголога для контроля функции слуха.

Частота осмотров сурдолога

1. **каждые 3 месяца** на первом году жизни;
2. **каждые 6 месяцев** до 3 лет;
3. **ежегодно** до 18 лет.

Инфекционист контролирует терапию, её побочные эффекты и отсроченные поражения.

Частота осмотров инфекциониста

1. **не реже 1 раза в 2–3 месяца** на первом году жизни;
2. далее по показаниям.

Офтальмолог оценивает зрение и отдалённые последствия.

Частота осмотров офтальмолога

1. недоношенные с риском ретинопатии: не реже 1 раза в 2 недели **до 6 месяцев**;
2. доношенные и поздние недоношенные без риска ретинопатии: 1 раз в месяц **до 6 месяцев**;
3. после 6 месяцев: 1 раз в 3 месяца **до 1 года**, 2 раза в год **до 3 лет**, затем ежегодно **до 18 лет**.

Страбизм, нистагм, атрофия зрительного нерва, корковое нарушение зрения, реактивация хориоретинита развиваются в течение всего детства, при субклинической форме — вплоть до 17 лет.

Невролог наблюдает ребёнка **ежегодно до 7 лет** или чаще.

Частота осмотров невролога

1. субклиническая и лёгкая формы: в 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев;
2. среднетяжёлая и тяжёлая форма с поражением ЦНС: ежемесячно **до 3 месяцев**, затем 1 раз в 3 месяца **до 1,5 лет**, далее 1 раз в 6 месяцев **до 7 лет**.

Профилактика у беременных проводится по клиническим рекомендациям «Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) у взрослых».

5.2 Организация медицинской помощи

Показания к переводу в профильное отделение

1. подозрение на клиническую форму врождённой ЦМВИ: перевод из акушерского стационара в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей или отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых.

Лечение клинической формы начинается в стационаре и продолжается амбулаторно пероральным препаратом при стабильном состоянии.

Новорождённых от матерей с первичной ЦМВИ во время беременности и (или) с антенатальными признаками врождённой ЦМВИ, но без характерных проявлений после рождения, по возможности направляют на второй этап выхаживания для обследования.

Ребёнок не переведён на второй этап выхаживания или не прошёл скрининг слуха методом отоакустической эмиссии

1. в выписке указывают необходимость обследования и наблюдения для исключения субклинической формы, в том числе изолированного снижения слуха;
2. верификацию проводят амбулаторно педиатр и инфекционист.

При выявлении клинической формы амбулаторно, невозможности ПЦР на ДНК ЦМВ или неинформативности серологических исследований ребёнка направляют по региональной маршрутизации в профильную медицинскую организацию.

Показания к выписке

1. стабильное удовлетворительное состояние;
2. стабилизация лабораторных показателей;
3. отсутствие противопоказаний к выписке.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Врожденная цитомегаловирусная инфекция»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 08.07.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2029 года

Код в рубрикаторе	260_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество неонатологов; Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Срок контроля слуха задан по-разному: в разделе 1.6 мониторинг слуха продолжают «до школьного возраста», в разделе 5 осмотры сурдолога-оториноларинголога — ежегодно до 18 лет. На странице приведён более длительный срок из раздела 5.

Клинические рекомендации

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K21** — Гастроэзофагеальный рефлюкс **K21.0** — Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом **K21.9** — Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 30.09.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Союз педиатров России; Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"; Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"; Национальная ассоциация детских реабилитологов; Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/402_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — состояние, при котором заброс содержимого желудка в пищевод вызывает беспокоящие симптомы и (или) осложнения.
- Оториноларингологические проявления ГЭРБ: першение и охриплость голоса, гипертрофия аденоидов (после исключения персистирующих вирусных инфекций и аллергического ринита), рецидивирующие отиты; у детей старшего возраста также ночной храп и утренний кашель.
- Диагноз устанавливается только при стойкой «пищеводной» симптоматике или чёткой связи симптомов с эпизодами рефлюкса после исключения альтернативных диагнозов.
- Грудным детям с неосложнённым рефлюксом лекарства рутинно не назначаются: симптомы, как правило, исчезают самостоятельно **после 6 месяцев**. Сначала применяют терапию положением, затем антирефлюксные смеси.
- Детям **старше 1 года** с пищеводными проявлениями препаратами выбора являются ингибиторы протонного насоса курсом **4–8 недель**.
- Фундопликация по Ниссену рассматривается при рефрактерном течении (нет ремиссии за **4–8 недель** приёма ингибиторов протонного насоса) и жизнеугрожающих осложнениях, только при чётко доказанной ГЭРБ и после исключения других причин симптомов.
- Неотложная госпитализация показана при повторяющихся эпизодах апноэ и обильном кровотечении из эрозий или язв пищевода.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) — непроизвольный ретроградный заброс желудочного либо желудочно-кишечного содержимого в пищевод.

У детей старшего возраста ГЭРБ понимается шире: хроническое рецидивирующее заболевание с нарушением моторно-эвакуаторной функции верхних отделов ЖКТ, регулярным забросом содержимого в пищевод, пищеводными и внепищеводными симптомами, повреждением слизистой оболочки дистального отдела пищевода вплоть до эрозивно-язвенного эзофагита и цилиндроклеточной метаплазии. У детей раннего возраста ведущее значение имеет морфофункциональная незрелость.

2.2 Этиология и патогенез

Непосредственной причиной ГЭРБ является гастроэзофагеальный рефлюкс. Заболевание развивается при нарушении равновесия между факторами агрессии (гиперсекреция соляной кислоты, лизолецитин, желчные кислоты, панкреатический сок при дуоденогастральном рефлюксе, некоторые лекарства и продукты) и факторами защиты (антирефлюксная функция кардии, резистентность слизистой оболочки, клиренс пищевода, своевременная эвакуация из желудка).

У подростков распространённость ГЭРБ составляет 12,4–18,8%. У детей с неврологическими нарушениями, хроническими заболеваниями лёгких (в том числе муковисцидозом), ожирением и после операций по поводу пороков развития пищевода ГЭРБ выявляется более чем в 70% случаев.

2.3 Классификация

1. **неэрозивная (НЭРБ)**: протекает без видимых эрозий слизистой оболочки пищевода, включая эндоскопически негативную форму; составляет около 60% случаев;
2. **эрозивная (эрозивный эзофагит)**: протекает с эрозиями слизистой оболочки пищевода; составляет около 35% случаев; указывают стадию A–D по Лос-Анджелесской классификации.

Внепищеводные проявления

1. бронхолёгочные;
2. оториноларингологические;
3. кардиологические;
4. стоматологические.

Осложнения

1. язва пищевода, кровотечение, перфорация;
2. стриктура или стеноз пищевода;
3. постгеморрагическая анемия;
4. пищевод Барретта.

Лос-Анджелесская классификация эрозивного рефлюкс-эзофагита (1994)

Стадия	Эндоскопические критерии
A	одно или более повреждений слизистой оболочки, каждое не более 5 мм в длину
B	хотя бы один дефект более 5 мм в длину, не распространяющийся между вершинами соседних складок
C	хотя бы один дефект, распространяющийся между вершинами соседних складок, но не циркулярный (менее 75% окружности пищевода)
D	дефект, занимающий не менее 75% окружности пищевода

Лос-Анджелесская классификация не содержит критериев неэрозивных изменений слизистой оболочки, поэтому врач-эндоскопист описывает признаки минимально выраженного или неэрозивного рефлюкс-эзофагита в протоколе отдельно.

2.4 Клиническая картина

Пищеводные симптомы

1. **изжога** — ключевая жалоба подростков, у детей дошкольного и младшего школьного возраста может отсутствовать;
2. **регургитация** — пассивное продвижение желудочного содержимого в нижнюю часть глотки, полость рта и за её пределы; усиливается лёжа и при наклоне туловища;
3. **отрыжка** воздухом, кислым, горьким; отрыжку кислым пациенты нередко принимают за изжогу.

Боль и нарушение глотания

1. **боль за грудиной, одинофагия** — у детей встречается относительно редко;
2. **дисфагия** — ощущение препятствия прохождению пищи; после любой пищи более характерна для эзофагита, после жидкой — для функциональных нарушений, после твёрдой нередко указывает на органическую патологию (опухоль, стриктура, стеноз);
3. **парадоксальная дисфагия** (симптом Лихтенштерна) — твёрдая пища проходит лучше жидкой.

Ком в горле (globus pharyngeus) — ощущение кома в горле, не связанное с глотанием. Возникает из-за отражённых болей при эзофагите, дискоординации мышц пищевода, крикофарингеальной гипертензии или прямого раздражения рефлюксатом слизистой оболочки гортани.

Внепищеводные симптомы

1. длительный хронический кашель, ночные приступы кашля и (или) удушья после обильной еды;
2. рецидивирующий бронхит, пневмония;
3. апноэ у детей раннего возраста;
4. периодическое першение и охриплость голоса;
5. гипертрофия аденоидов — при исключении хронических персистирующих вирусных инфекций и аллергического ринита;
6. рецидивирующие отиты;
7. нарушения ритма и проводимости сердца;
8. эрозии эмали зубов.

Изолированно, без основных жалоб, внепищеводные проявления встречаются редко. Иногда ГЭРБ выявляется только при эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), выполненной по поводу патологии желудка и двенадцатиперстной кишки.

Дети раннего возраста

1. рецидивирующие рвоты, срыгивания;
2. снижение массы тела;
3. рвота фонтаном, рвота с примесью крови или желчи;
4. респираторные нарушения вплоть до апноэ и синдрома внезапной смерти.

Частота срыгиваний снижается с 50–66% в первом полугодии до 5–10% к концу первого года жизни.

Степень тяжести срыгиваний у детей первого года жизни

Степень тяжести	Срыгивания
лёгкое течение	до 3–5 срыгиваний в день, объёмом 2,5–5,0 (единица измерения в КР не указана)
среднетяжёлое течение	в половине кормлений или чаще, до 1/2 объёма съеденной пищи
тяжёлое течение	более чем в половине кормлений, объём более 1/2 кормления и (или) отставание в физическом развитии

Патологический рефлюкс у детей первого года жизни встречается с частотой 8–11%. Среди причин выделяют натальную травму шейного отдела позвоночника, аллергию к белкам коровьего молока, лактазную недостаточность, скользящую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, нарушение вегетативной регуляции, недоношенность.

У детей первого года жизни и раннего возраста судить о наличии и выраженности эзофагита только по клиническим проявлениям невозможно.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. жалоб с учётом выраженности симптомов: у детей раннего возраста субъективные симптомы ненадёжны, большинство симптомов неспецифичны;
2. анамнеза: заболевания, при которых ГЭРБ встречается чаще, ранее установленный диагноз ГЭРБ;
3. инструментальных данных при необходимости: рентгеноскопия пищевода с контрастированием, ЭГДС, pH-метрия, pH-импедансометрия, манометрия.

Диагноз ГЭРБ устанавливается только при стойкой клинической («пищеводной») симптоматике или при чёткой связи симптомов с эпизодами рефлюкса и исключении альтернативных диагнозов.

ГЭРБ считается рефрактерной при отсутствии убедительной клинической и эндоскопической ремиссии в течение **4–8 недель** терапии стандартной дозой ингибиторов протонного насоса.

3.2 Жалобы и анамнез

Симптомы у детей первого года жизни и раннего возраста

1. персистирующие срыгивания, рвоты;
2. повышенное беспокойство, плач, усиливающиеся во время кормления;
3. снижение аппетита, отказ от еды, затруднения при глотании;
4. в тяжёлых случаях — плохие прибавки массы тела;
5. персистирующий кашель, стридор, в тяжёлых случаях — апноэ и аспирационная пневмония;
6. персистирующая икота.

Симптомы у детей старшего возраста

1. персистирующие рвоты;
2. изжога, дисфагия, отрыжка, боль за грудиной;
3. кислый, горький или другой неприятный привкус во рту;
4. ночной храп как проявление синдрома обструктивного апноэ сна;
5. утренний кашель, осиплость голоса;
6. поражение зубной эмали.

Специфических симптомов ГЭРБ нет, поэтому для дифференциальной диагностики оценивают симптомы тревоги.

Симптомы тревоги

1. рвота с примесью желчи, ночная или упорная рвота;
2. стойкая дисфагия;
3. увеличение живота в объёме;
4. гематемезис;
5. лихорадка;
6. патологические изменения при осмотре со стороны ЖКТ, дыхательной, сердечно-сосудистой или нервной системы;
7. потеря массы тела, отставание в физическом развитии;
8. нарушение психомоторного развития;
9. рецидивирующие бронхиты, пневмонии.

Если диагноз ГЭРБ не подтверждён, по алгоритму КР проводится диагностический поиск в рамках других заболеваний с консультациями оториноларинголога и пульмонолога; при осложнениях показана консультация детского хирурга.

3.3 Визуальный осмотр, пальпация, аускультация

Ребёнку с клиническими признаками ГЭРБ показан стандартный полный осмотр: визуальный осмотр, пальпация, аускультация. Патогномоничных для ГЭРБ физикальных симптомов нет.

3.4 Общий (клинический) анализ крови

При рвоте и плохой прибавке массы тела выполняется общий развёрнутый анализ крови для исключения инфекционной природы симптомов и сопутствующих состояний, таких как анемия.

Анемия носит железодефицитный характер: гипохромная, микро- или нормоцитарная, норморегенераторная; уровень железа и ферритина снижен, железосвязывающая способность сыворотки повышена.

3.5 Кислотно-основное состояние и электролиты крови

При рвоте и плохой прибавке массы тела определяют pH и буферные основания крови, натрий, калий и хлориды для контроля водно-электролитного состояния и исключения ацетонемического синдрома.

3.6 Исследование кала на скрытую кровь

Детям **до 1 года** с рвотой и плохой прибавкой массы тела показано исследование кала на скрытую кровь, желательно иммунохимическим методом: в этом возрасте подобные жалобы нередко обусловлены аллергией к белкам коровьего молока.

3.7 Ультразвуковое исследование пищевода с водно-сифонной пробой

Показание: подозрение на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы; после УЗИ выполняется рентгеноскопия желудка.

Нормальный диаметр пищевода у детей 7–10 мм. При диаметре **более 13 мм** (во время глотка **15 мм и более**) заключение о скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы становится практически достоверным.

Для диагностики самой ГЭРБ УЗИ Европейским обществом детских гастроэнтерологов не рекомендуется: чувствительность около 95%, специфичность 11%.

3.8 Эзофагогастродуоденоскопия

ЭГДС проводится детям с подозрением на ГЭРБ для диагностики и дифференциальной диагностики; обязательна при симптомах тревоги.

Исследование позволяет

1. выявить врождённые аномалии верхних отделов ЖКТ (атрезии, стенозы, «короткий пищевод»);
2. диагностировать эрозивный рефлюкс-эзофагит;
3. выявить осложнения: пептический стеноз, язвы пищевода, пищевод Барретта;
4. исключить эозинофильный и инфекционный эзофагит, воспалительные заболевания кишечника;
5. выявить грыжу пищеводного отверстия диафрагмы;
6. выявить опухоли и проконтролировать пищевод после операций.

Эрозивные дефекты слизистой оболочки (без уточнения размера) при наличии симптомов подтверждают диагноз; тяжесть оценивают по Лос-Анджелесской классификации.

Нормальная эндоскопическая картина ГЭРБ не исключает. Лечение ингибиторами протонного насоса до ЭГДС переводит эрозивную форму в неэрозивную и снижает чувствительность исследования.

Признаки минимально выраженного рефлюкс-эзофагита (фиксируются в протоколе)

1. спрямление, уплотнение, мелкие треугольные выпячивания и сегментарные подъёмы Z-линии менее 10 мм;
2. гиперемия и мельчайшие эрозии в зоне пищеводно-желудочного соединения;
3. реактивная гиперплазия кардиального эпителия с гиперпластическими полипами или без них;
4. линейное утолщение слизистой оболочки по верхушкам складок нижней трети пищевода (белесые полосы).

При технической возможности используют осмотр в узком спектре света.

Детям ЭГДС, по возможности, проводится под общей анестезией или глубокой седацией.

Биопсия пищевода с гистологическим исследованием проводится для дифференциальной диагностики (эозинофильный эзофагит, болезнь Крона, инфекционный эзофагит) и своевременного выявления пищевода Барретта.

Берут не менее двух биоптатов (лучше четыре) на **2 см и более выше Z-линии**. Микроскопические изменения ГЭРБ не подтверждают и не исключают, поэтому рутинная биопсия для диагностики ГЭРБ нецелесообразна.

Пищевод Барретта диагностируется по эндоскопическому и гистологическому критериям. Сегмент метаплазии описывают по Пражским критериям C&M; при подозрении используют формулировку «подозрение на цилиндроклеточную метаплазию пищевода» с указанием протяжённости и берут множественные биоптаты. Группа риска поздней диагностики — дети с тяжёлой патологией опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью (ДЦП).

Выполняется четырёхквадрантная биопсия через каждый 1 см циркулярного сегмента метаплазии, больше биоптатов — у проксимального края «языков пламени». При обнаружении цилиндрического эпителия устанавливается диагноз пищевода Барретта независимо от наличия кишечной метаплазии и длины сегмента.

3.9 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием

Показания: рефрактерное течение (нет ремиссии за **4–8 недель** терапии) и подозрение на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы по данным ЭГДС; цель — дифференциальная диагностика и выявление анатомических аномалий.

У детей первого года жизни показанием является повторяющаяся рвота давностью **более 3 суток**, если нет симптомов, определённо указывающих на механическую или функциональную непроходимость.

Исследование выполняется натощак, перед очередным кормлением. Объём бария сульфата соответствует разовому кормлению: детям **до 3 месяцев** 40–80 мл, старше — 60–200 мл; более 200 мл давать нецелесообразно.

Водно-сифонная проба (питьё воды лёжа) положительна при забросе бария из желудка в пищевод. У младенцев проба с компрессией живота положительна при двух и более эпизодах заброса за 30 секунд. При отрицательном результате осматривают в положении Тренделенбурга; нагрузочная проба с густым барием оценивает моторику пищевода и работу сфинктеров.

3.10 Внутрипищеводная pH-метрия

Показания (при возможности): подозрение на неэрозивную или рефрактерную ГЭРБ, выраженные и (или) стойкие внепищеводные симптомы. Метод регистрирует только кислые рефлюксы.

Один из электродов устанавливают на 5 см выше кардии. Нормативы T. R. DeMeester применимы у детей **старше 12 лет**, а у детей до года используют нормативы J. Boix-Ochoa. При кислотном рефлюксе нормальный индекс рефлюкса (доля времени с pH < 4) составляет 4,45%.

Метод доступен не везде, поэтому ребёнка направляют в специализированный стационар или консультативный центр.

Нормальные показатели суточной pH-метрии по T. R. DeMeester

Показатель	Норма
время с pH < 4, общее	4,5%
время с pH < 4, стоя	8,4%
время с pH < 4, лёжа	3,5%
число эпизодов рефлюкса	46,9

Показатель	Норма
число эпизодов рефлюкса длительнее 5 минут	3,5
самый длинный эпизод с pH < 4	20 минут

Нормальные показатели суточной pH-метрии у детей до 1 года по J. Boix-Ochoa

Показатель	Среднее значение	Верхняя граница нормы
общее время с pH < 4	1,9 ± 1,6%	5,0%
число эпизодов рефлюкса	10,6 ± 8,8	27,0
число эпизодов длительнее 5 минут	1,7 ± 1,2	5,8
самый длинный эпизод, минуты	8,1 ± 7,2	22,5

3.11 Суточная pH-импедансометрия

Показания (при возможности)

1. рефрактерная ГЭРБ;
2. неэрозивная ГЭРБ;
3. выраженные внепищеводные симптомы.

Исследование позволяет

1. уточнить характер рефлюкса: кислотный, щелочной, смешанный;
2. связать симптомы (кашель, боль за грудиной) с эпизодами рефлюкса;
3. выявить детей со свистящим дыханием и другими респираторными симптомами, у которых рефлюкс является отягощающим фактором.

Метод выявляет и некислотный рефлюкс, определяет высоту заброса и риск аспирации. Щелочной и смешанный рефлюкс выявляются не менее чем у половины детей; норм для щелочного рефлюкса нет, сам факт заброса дуоденального содержимого в пищевод патологичен.

3.12 Пищеводная манометрия

Показания (селективно): отсутствие ремиссии за **4–8 недель** стандартной терапии, подозрение на нарушение моторики пищевода, предстоящая антирефлюксная операция.

Нижние границы нормы нижнего пищеводного сфинктера: давление 6 мм рт. ст., длина 2 см, внутрибрюшной сегмент 1 см. Исследование сложно провести у детей младше 15 лет.

3.13 Дифференциальная диагностика

1. **заболевания пищевода**: острый и хронический эзофагит, язва, стеноз, дивертикулы, опухоли пищевода, склеродермия, сидеропения;
2. **заболевания нервной и мышечной систем**: эзофагоспазм, атония пищевода, ахалазия кардии;
3. **сдавление пищевода соседними органами**: опухоли и кисты средостения, инородные тела, задний медиастинит, плевропульмональный фиброз, митральный порок, аневризма и праволежащая аорта, аномалии сосудов, увеличение щитовидной железы;
4. **другие причины**: лекарственное воздействие, психические заболевания.

4. Лечение

Тактика у детей с ГЭРБ

1. стартовое лечение ингибиторами протонного насоса около **8 недель**;
2. наблюдение после отмены препарата;
3. при возвращении симптомов — рентгеноконтрастное и при необходимости другие инструментальные исследования;
4. при отсутствии эффекта — рассмотреть хирургическое лечение (лечение, наблюдение и оценка результатов занимают в среднем около **1 года**).

Терапия комплексная, ступенчатая: нормализация образа жизни, режима дня и питания; медикаментозная терапия (моторика пищевода и желудка, кислотообразование, восстановление слизистой оболочки); хирургическое лечение.

4.1 Лечение детей первого года жизни и раннего возраста

Первый шаг — терапия положением: при кормлении ребёнка держат под углом **45–60°**, ночью головной конец кроватки приподнимают на **10–15 см**. Перекармливание недопустимо.

При неэффективности терапии положением назначают антирефлюксные молочные смеси с загустителями: они уменьшают частоту рефлюкса.

Варианты назначения антирефлюксной смеси

1. в начале каждого кормления адаптированной смесью — 1/2–1/4 объёма кормления;
2. 1–3 раза в день в объёме кормления, в остальные кормления — адаптированная смесь;
3. в полном суточном объёме, длительность индивидуально.

При отсутствии эффекта и плохих прибавках массы тела применяют смесь на основе глубокого гидролиза белка или аминокислотную. Отсутствие улучшения за **2 недели** свидетельствует о неэффективности, и ребёнка возвращают на прежнюю смесь. При положительном эффекте смесь продолжают **до 12 месяцев, но не менее 6 месяцев**.

Смеси с неперевариваемыми полисахаридами (камедь рожкового дерева) лечебные и назначаются врачом: объём подбирают (1/2, 1/3 или 1/4 суточного рациона), длительность — по клинике, до 2–3 месяцев; здоровым детям без срыгиваний не рекомендуются. Вместе с терапией положением эффективны в 90–95% случаев.

Грудным детям с неосложнённым рефлюксом медикаментозная терапия рутинно не рекомендуется: в большинстве случаев симптомы исчезают самостоятельно **после 6 месяцев**.

Вопрос о медикаментозном лечении грудных детей с синдромом срыгивания решается строго индивидуально и схематизации не подлежит.

Ингибиторы протонного насоса показаны детям **старше 1 года** с выраженными симптомами (беспокойство, отказ от кормления, плохая прибавка массы тела) и эзофагитом средней и тяжёлой степени при неэффективности немедикаментозного лечения. Дозы назначают согласно инструкции.

4.2 Немедикаментозное лечение детей старшего возраста

Всем детям и подросткам с ГЭРБ рекомендуется изменение образа жизни.

Рекомендации по изменению образа жизни

1. спать с головным концом кровати, приподнятым не менее чем на 15 см;
2. снизить содержание жира и объём пищи, повысить содержание белка, избегать раздражающих продуктов (цитрусовые соки, томаты, кофе, чай, шоколад, мята, лук, чеснок);
3. снизить массу тела при ожирении;
4. не есть перед сном, не лежать после еды;
5. избегать тесной одежды и тугих поясов;
6. избегать глубоких наклонов, длительного пребывания в согнутом положении, подъёма тяжестей более 8–10 кг, упражнений с напряжением мышц брюшного пресса;
7. избегать седативных, снотворных средств, транквилизаторов, антагонистов кальция, теофиллина, холинолитиков;
8. прекратить курение.

Жиры снижают давление нижнего пищеводного сфинктера, белки повышают; кофе, чай, шоколад, мята, алкоголь и курение снижают давление сфинктера.

ГЭРБ, как правило, сочетается с гастритом, гастродуоденитом, заболеваниями желчевыводящих путей, поджелудочной железы и кишечника, поэтому базисной диетой являются столы 1, 5, 4. Изголовье поднимают брусками высотой до 15 см под ножки кровати, а не подушками; сон на левом боку уменьшает частоту рефлюкса. Слабоминерализованные щелочные воды принимают в тёплом дегазированном виде за 30–40 минут до еды в течение 4 недель.

4.3 Медикаментозное лечение детей старшего возраста

Детям старше года с пищеводными проявлениями ГЭРБ препаратами выбора являются ингибиторы протонного насоса: омепразол, эзомепразол, #рабепразол — курсом **4–8 недель**, при подтверждённом эзофагите дольше.

1. омепразол — детям **старше 2 лет** 1–4 мг/кг в сутки, максимально 40 мг (в КР одновременно указано «в два приёма» и «1 раз в сутки»);
2. эзомепразол — детям **старше 1 года** 0,5 мг/кг в 1–2 приёма, максимально 40 мг 1–2 раза в сутки;
3. рабепразол — **с 12 лет** до 20 мг в сутки.

При приёме **более 8 недель** учитывают повышение риска метаболических, инфекционных и пищевых расстройств. По эффективности ингибиторы протонного насоса превосходят блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов.

Детям **старше 6 лет** вместе с ингибиторами протонного насоса рекомендуется средство для создания желудочно-пищеводного барьера: натрия гиалуронат и хондроитина сульфат на биоадгезивном носителе полоксамере 407.

Сочетание эффективнее монотерапии ингибиторами протонного насоса в устранении пищеводных и внепищеводных симптомов и эпителизации эрозий.

По 1 пакетику (10 мл) после еды и на ночь; эффективность доказана при применении **4–5 недель**.

При сочетании пищеводных и внепищеводных симптомов внепищеводные симптомы полностью исчезли у 70,5% детей; доля принимавших антациды снизилась с 34,4 до 4,9%.

При невозможности приёма ингибиторов протонного насоса или противопоказаниях селективно применяют #фамотидин 1 мг/кг в сутки курсом **4–8 недель** при эрозивном эзофагите у детей **старше 3 лет**.

Применяется с осторожностью: эффективность ниже, фармакотерапевтический профиль неблагоприятен, высок риск тахифилаксии.

Для быстрого купирования изжоги в комплексной терапии назначают антациды, преимущественно в виде геля или суспензии. Длительно для лечения ГЭРБ не применяются.

1. алюминия фосфат: возраст в КР не указан;
2. алгелдрат + магния гидроксид — **с 10 лет**;
3. натрия алгинат + натрия гидрокарбонат + кальция карбонат — **с 12 лет**.

Синтетические антихолинергические средства и прокинетики применяются селективно: при сопутствующей задержке эвакуации из желудка и (или) запоре; наибольший эффект — при сочетании ГЭРБ с функциональной диспепсией.

Тримебутин

1. дети 3–5 лет: 25 мг 3 раза в сутки;
2. дети 6–12 лет: 50 мг 3 раза в сутки;
3. 12 лет и старше: 100–200 мг 3 раза в сутки.

Итоприд

1. возраст: с 16 лет.

4.4 Противорецидивное лечение

В период стойкой клинико-морфологической ремиссии ингибиторы протонного насоса, блокаторы H2-гистаминовых рецепторов, прокинетики и антациды не рекомендуются.

Для профилактики рецидивов селективно проводятся реабилитационные мероприятия: бальнеолечение, физиотерапия.

ГЭРБ часто протекает на фоне хронического гастродуоденита и колонизации Helicobacter pylori, поэтому в наблюдение включают обследование и ведение по клиническим рекомендациям о патологии желудка и двенадцатиперстной кишки.

Занятия физкультурой рекомендуются в подготовительной группе при неполной клинико-эндоскопической ремиссии и в основной группе при полной.

4.5 Хирургическое лечение

Показания к фундопликации (лапароскопической, по Ниссену)

1. рефрактерность к медикаментозной терапии, то есть отсутствие убедительной клинической и эндоскопической ремиссии за **4–8 недель** стандартной дозы ингибиторов протонного насоса, необходимость постоянной фармакотерапии для контроля симптомов, наличие стриктуры пищевода или пищевода Барретта;
2. жизнеугрожающие осложнения: эпизоды апноэ, рецидивирующая аспирация, реактивные заболевания дыхательных путей, неврологические нарушения, задержка физического развития;
3. тяжёлое основное заболевание (неврологическое, муковисцидоз) при значимом риске осложнений ГЭРБ.

Антирефлюксная хирургия может быть полезна также детям с подтверждённой ГЭРБ, которые не могут придерживаться оптимальной медикаментозной терапии.

Перед операцией исключают причины симптомов, не связанные с ГЭРБ; оперируют только детей с чётко доказанной хронической или рецидивирующей ГЭРБ, взвесив риск и пользу.

Риски фундопликации: вздутие живота, раннее насыщение, дисфагия, позывы на рвоту, демпинг-синдром, аспирация из-за застоя в пищеводе, несостоятельность манжеты с повторной операцией.

Лапароскопическая фундопликация по Ниссену является золотым стандартом и в значительной степени заменила открытую операцию: меньше травматичность и пребывание в стационаре. Робот-ассистированная операция безопасна, но существенных преимуществ не даёт.

Наименьший успех антирефлюксная хирургия даёт при внепищеводных симптомах, включая аспирационную пневмонию, у детей с неврологическими нарушениями.

4.6 Иное лечение

Детям с ГЭРБ и неврологическими нарушениями, проблемами с кормлением, недостаточным набором массы тела селективно проводится кормление через гастростому — для предотвращения осложнений и улучшения нутритивного статуса.

Кормление через гастростому, как правило, проводится без хирургического антирефлюксного лечения, на фоне медикаментозной антирефлюксной терапии по показаниям; при отсутствии эффекта второй линией является хирургическое лечение.

При тяжёлой ГЭРБ и высоком риске аспирации (тяжёлые неврологические нарушения), синдроме короткой кишки с тяжёлой ГЭРБ или дисморикой, когда пероральное и желудочное питание неэффективны, альтернативой фундопликации и гастростоме является кормление через назоеюнальный зонд.

4.7 Медицинская реабилитация

Коррекция образа жизни с обучением позиционированию

1. исключается положение лёжа на спине после еды;
2. сон на левом боку: на правом боку рефлюкс усиливается;
3. после еды допустимо жевание резинки без сахара;
4. исключают кофеин, газированные напитки, шоколад, цитрусовые, томаты, острую и жирную пищу, жирные молочные продукты.

Для улучшения глотания и уменьшения дисфагии селективно назначается лечебная физкультура по методике Р. Шейкер.

Лёжа на спине без подушки поднять голову (смотреть на пальцы ног), не отрывая плеч, удерживать 1 минуту, опустить; повторить ещё 2 раза с отдыхом по 1 минуте. Затем 30 раз поднять и опустить голову.

Для уменьшения дисфагии и изжоги селективно проводится санаторно-курортное лечение: питьевые минеральные воды, терренкуры, климатотерапия.

Возможно применение физиотерапии: синусоидальные модулированные токи, электросон, СВЧ-терапия, структурно-резонансная электромагнитотерапия, низкочастотная магнитотерапия.

Противопоказания к физическим факторам

1. тяжёлая ГЭРБ, осложнённая стриктурами, язвами, кровотечением из вен пищевода;
2. грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, подлежащая операции;
3. пищевод Барретта;
4. доброкачественная или злокачественная опухоль;
5. общие противопоказания к физической терапии.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Как правило, лечение в круглосуточном стационаре не требуется, за исключением осложнённого течения и показаний к операции. Для диагностики, коррекции терапии и реабилитации целесообразен дневной стационар.

Показания к неотложной госпитализации

1. повторяющиеся эпизоды апноэ;
2. обильное кровотечение из эрозий или язв пищевода.

Показания к срочной консультации детского хирурга

1. дисфагия;
2. потеря массы тела;
3. гематемезис;
4. рецидивирующая рвота.

Дети с ГЭРБ наблюдаются педиатром или врачом общей практики и гастроэнтерологом, при сопутствующей патологии совместно с соответствующими специалистами.

Осложнённое течение (стриктуры, кровотечения, пищевод Барретта) ведётся совместно с детским хирургом; при подозрении на малигнизацию ребёнка с пищеводом Барретта направляют к детскому онкологу.

5.2 Диспансерное наблюдение

Осмотры педиатра и (или) гастроэнтеролога — **не реже 2 раз в год в течение 3 лет** с момента последнего обращения.

Частота ЭГДС

1. эндоскопически негативная форма и рефлюкс-эзофагит I степени — при обострении;
2. рефлюкс-эзофагит II–III степени — **1 раз в год** и при обострении;
3. рефлюкс-эзофагит IV степени (язва, пищевод Барретта) — **1 раз в 6 месяцев** на первом году, затем **1 раз в год** при клинической ремиссии.

В КР частота ЭГДС задана по степеням рефлюкс-эзофагита I–IV; соответствие Лос-Анджелесским стадиям A–D (вкладка «Клиника») не приведено.

5.3 Профилактика

Меры профилактики в основном совпадают с рекомендациями по изменению образа жизни (вкладка «Лечение»); полный перечень раздела 5.1 КР — в «Подробнее».

Профилактика

1. борьба с лишним весом;
2. ограничение продуктов, повышающих внутрибрюшное давление (газированные напитки, бобовые) и усиливающих рефлюкс (кофе, шоколад, жирная и острая пища);
3. ограничение продуктов с кислотостимулирующим действием (мучные изделия, цитрусовые, специи, жареное, редька, редис);
4. еда небольшими порциями, медленно, без разговоров;
5. подъём тяжестей не более 8–10 кг;
6. изголовье кровати приподнято на 10–15 см;
7. ограничение лекарств, расслабляющих пищеводный сфинктер;
8. не принимать горизонтальное положение **2–3 часа** после еды;
9. разъяснение вреда табачного дыма и алкоголя.

ГЭРБ не является противопоказанием к вакцинации вакцинами любого типа.

5.4 Осложнения и прогноз

Грозные осложнения ГЭРБ — пептическая стриктура пищевода при рубцевании язв, пищевод Барретта (предраковое состояние; у детей с эзофагитом 6,2–13%) и постгеморрагическая анемия при скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы или эрозивно-язвенном поражении.

У большинства детей прогноз благоприятный. При пищеводе Барретта сохраняется вероятность аденокарциномы или плоскоклеточного рака; неблагоприятные признаки — метаплазия на протяжении 8 см и более и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 30.09.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2028 года
Код в рубрикаторе	`402_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Российская ассоциация детских хирургов; Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов; Национальная ассоциация детских реабилитологов; Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Доза омепразола: в одной фразе указано «до 40 мг в два приема» и «1 раз в сутки» (раздел 3.1.2).
- Обобщённый показатель DeMeester «в норме не должен превышать значений» — пороговое число в тексте пропущено (раздел 2.4).
- Частота ЭГДС при диспансерном наблюдении задана по степеням рефлюкс-эзофагита I–IV, а классификацией в разделе 1.5 служит Лос-Анджелесская (стадии A–D); соответствие степеней и стадий не приведено (раздел 5.2).
- Объём срыгиваний при лёгком течении («объемом 2,5-5,0») приведён без единицы измерения (раздел 1.6).

Клинические рекомендации

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.1** — Хронический назофарингит **J35.1** — Гипертрофия миндалин **J35.2** — Гипертрофия аденоидов **J35.3** — Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/662_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Наличие у ребёнка глоточной и нёбных миндалин само по себе не является патологией. Показанием к обследованию служат жалобы, клинические проявления или сопутствующее заболевание, на течение которого могут влиять аденоиды и нёбные миндалины.
- **Критерии диагноза**
  1. гипертрофия нёбных миндалин: жалобы, анамнез, фарингоскопия с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин;
  2. гипертрофия аденоидов: дополнительно инструментальное подтверждение: эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или компьютерная томография (КТ).
- Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей не проводится.
- **Лечебная тактика**
  1. есть показания: операция в плановом порядке;
  2. нет показаний или есть абсолютные противопоказания: динамическое наблюдение оториноларинголога.
- Консервативное лечение детей с гипертрофией аденоидов оправдано только при признаках аденоидита.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. гипертрофия аденоидов: увеличение глоточной миндалины со стойким затруднением носового дыхания и (или) осложнениями: обструктивные нарушения сна, экссудативный средний отит, деформация лицевого скелета;
2. гипертрофия нёбных миндалин: увеличение одной или обеих нёбных миндалин, которое протекает бессимптомно или сопровождается храпом, остановками дыхания во сне, нарушениями глотания и артикуляции, деформацией лицевого скелета.

Аденоидит: реактивные воспалительные изменения глоточной миндалины как органа местного иммунитета в ответ на антигены, попадающие на слизистую носа и глотки.

Острый синусит считается рецидивирующим при 4 и более эпизодах за последний год. Острый средний отит считается рецидивирующим при 3 и более эпизодах за 6 месяцев или 4 и более эпизодах за 12 месяцев.

2.2 Этиология

Наиболее вероятными причинами считают вирусную инфекцию, генетическую предрасположенность и воздействие окружающей среды; роль бактериальной инфекции, гастроэзофагеального рефлюкса и аллергии дискутабельна. У отдельного пациента, как правило, одновременно действует несколько факторов, поэтому ведущий выделить обычно не удаётся.

Особое внимание уделяется вирусу герпеса IV типа: герпетическая инфекция является одной из частых причин выраженной гипертрофии глоточной миндалины со стойкой обструкцией носоглотки.

2.3 Классификация

Классификация А. Г. Лихачёва: какую часть сошника прикрывает ткань глоточной миндалины.

1. I степень: не более верхней трети сошника;
2. II степень: от 1/3 до 2/3;
3. III степень: более 2/3.

Классификация Б. С. Преображенского: расстояние от вертикали через середину язычка до края передней (нёбно-язычной) дужки делят на три части.

1. I степень: миндалина занимает треть расстояния;
2. II степень: две трети;
3. III степень: миндалины достигают язычка и соприкасаются.

2.4 Клиническая картина

Жалобы и симптомы чаще всего отмечаются при гипертрофии III степени. При I и II степени пациенты, как правило, хотя и не всегда, жалоб не предъявляют.

Гипертрофия нёбных миндалин

1. храп: постоянный, часто не зависит от положения тела во сне (в отличие от храпа при воспалении);
2. в ряде случаев признаки синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС): дневная сонливость, снижение успеваемости;
3. значительно реже изменения прикуса и лёгкая дисфония.

Гипертрофия аденоидов

1. нарушения дыхания во сне;
2. стойкое затруднение носового дыхания: постоянно открытый рот, гипоназальность (закрытая гнусавость), сухость во рту;
3. снижение слуха при экссудативном среднем отите, повторные острые средние отиты;
4. даже при II степени после простуды заложенность, постназальный затёк и кашель **до нескольких недель**;
5. у школьников частые, в том числе рецидивирующие, острые синуситы.

Аденоидит

1. основная жалоба: кашель, как правило продуктивный, ночной и утренний (постназальный затёк);
2. может развиваться и при небольших размерах глоточной миндалины;
3. при гипертрофии аденоидов II–III степени одновременно заложенность носа и кашель.

Реактивные изменения глоточной миндалины после простуды или на фоне аллергического ринита у детей **младше 7–9 лет** физиологичны, если:

1. нет осложнений (средних отитов, острого синусита);
2. кашель или затруднение носового дыхания не нарушают сон и дневную активность.

Симптомы не патогномоничны.

Дифференцируют с

1. острым и хроническим риносинуситом;
2. аллергическим, вазомоторным и гипертрофическим ринитом;
3. искривлением перегородки носа;
4. инородными телами и новообразованиями полости носа и носоглотки.

Гипертрофия аденоидов часто сопутствует острому и хроническому синуситу и аллергическому риниту.

Клиническая картина у взрослых не отличается от таковой у детей.

2.5 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. длительность заболевания и с чем связано начало;
2. динамику жалоб и их влияние на сон и дневную активность;
3. проводившееся лечение, его эффект и нежелательные явления;
4. сохраняются ли симптомы вне эпизодов ОРВИ и как выражены сейчас по сравнению с прошлым;
5. сопутствующие, прежде всего аллергические, заболевания: наблюдение, лечение, планируемые операции;
6. перенесённые операции и манипуляции в полости носа, включая назотрахеальную интубацию и назальные зонды.

---

3. Диагностика

Обследование оправдано при

1. жалобах;
2. клинических проявлениях;
3. сопутствующем заболевании, на которое могут влиять аденоидит, гипертрофия аденоидов или нёбных миндалин.

Критерии диагноза

1. гипертрофия нёбных миндалин: жалобы, анамнез, физикальное обследование с фарингоскопией и обязательной оценкой нижнего полюса миндалин;
2. гипертрофия аденоидов: дополнительно эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или КТ.

3.1 Осмотр

Показания

1. каждый пациент: осмотр оториноларинголога (амбулаторно и при госпитализации).

Пальцевое исследование носоглотки детям в амбулаторной практике не проводят: результаты крайне субъективны, процедура неприятна и может травмировать структуры глотки.

Лабораторные исследования для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин не применяют; их используют лишь для диагностики сопутствующих заболеваний.

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Показания

1. симптомы, характерные для гипертрофии аденоидов.

Преимущества и ограничения

1. предпочтителен гибкий эндоскоп с сохранением изображения (фото или видео);
2. метод первого выбора для дифференциальной диагностики и оценки носоглотки после операции, в том числе в отдалённые сроки;
3. требуется правильная дезинфекция оптики после осмотра;
4. у эмоционально лабильных детей в поликлинике и консультативном кабинете исследование может быть затруднено;
5. ригидный эндоскоп дети, особенно дошкольники, переносят хуже;
6. осмотр без сохранения изображения значительно менее объективен при последующих консультациях.

3.3 Рентгенография носоглотки

Показания

1. симптомы, характерные для гипертрофии аденоидов: оценка размеров глоточной миндалины (боковая проекция).

Метод является недорогим, доступным и безболезненным. К недостаткам относятся небольшая лучевая нагрузка, необходимость правильной укладки с открытым ртом и невозможность дифференцировать аденоиды от других объёмных образований носоглотки; результат не всегда соответствует выраженности симптомов. После аденотомии рентгенография малоинформативна, поскольку не позволяет отличить аденоиды от компенсаторной гипертрофии трубных валиков и оценить рубцовые изменения.

3.4 Компьютерная томография

Показания к КТ верхних дыхательных путей и шеи

1. сложные случаи: дифференциальная диагностика гипертрофии аденоидов с другой патологией носа со сходными симптомами;
2. одновременная диагностика нескольких заболеваний.

КТ не должна проводиться всем пациентам для диагностики гипертрофии аденоидов.

3.5 Тимпанометрия

Показания

1. гипертрофия аденоидов: объективная оценка среднего уха.

3.6 Исследования, которые не показаны

Мазки из глотки на микрофлору для диагностики гипертрофии миндалин не показаны: условно-патогенные бактерии есть и у здоровых, рост или его отсутствие не говорит о риске и прогнозе.

3.7 Консультации специалистов

Консультация аллерголога-иммунолога при клинико-анамнестических признаках

1. аллергического ринита;
2. атопической бронхиальной астмы;
3. атопического дерматита.

В первую очередь при

1. глазных симптомах, повторяющемся чихании и зуде в носу;
2. ринологических симптомах, связанных с цветением, животными или другими ситуациями;
3. повторных приступах кашля, свистящего или затруднённого дыхания, стеснения в груди, особенно ночью и рано утром;
4. атопическом дерматите, крапивнице и других аллергических заболеваниях кожи;
5. рецидивирующих острых средних отитах или риносинуситах.

Консультация специалиста по расстройствам сна

1. признаки повторяющихся обструктивных нарушений сна.

Консультация ортодонта

1. врождённые или приобретённые изменения челюстно-лицевой области.

Консультация инфекциониста

1. подозрение на персистирующую вирусную, прежде всего герпесвирусную, инфекцию.

Показание: хотя бы один признак, сохраняющийся **3 месяца и более**:

1. увеличение лимфатических узлов в 3 группах и более (не менее 3 узлов в каждой);
2. увеличение печени и (или) селезёнки;
3. абсолютное число нейтрофилов ниже возрастной нормы и (или) общее число нейтрофилов ниже 5×10^9/л.

Оториноларинголог оценивает симптомы, решение о лабораторном поиске вирусов принимает инфекционист.

---

4. Лечение

4.1 Тактика

1. есть показания: хирургическое лечение в плановом порядке;
2. нет показаний или есть абсолютные противопоказания: динамическое наблюдение оториноларинголога;
3. хроническая или врождённая сопутствующая патология: операция только по согласованию с профильным специалистом.

Абсолютные противопоказания к операции

1. шок;
2. острая стадия инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения;
3. поздние стадии тяжёлых инфекционных и онкологических заболеваний;
4. тяжёлое, крайне тяжёлое или терминальное состояние из-за сопутствующих заболеваний.

Относительные противопоказания

1. неконтролируемое или плохо контролируемое течение сопутствующей соматической патологии;
2. аномалии строения носа, резко повышающие риск серьёзных интраоперационных осложнений.

Консервативное лечение оправдано только при клинических и анамнестических признаках воспаления глоточной миндалины (аденоидита) или нёбных миндалин (тонзиллита) при наличии соответствующих жалоб или осложнений.

4.2 Аденотомия

Аденотомия: восстановление проходимости носоглотки при отсутствии противопоказаний.

Показания к аденотомии у детей

1. частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна: храп, в ряде случаев дневная сонливость и вялость;
2. персистирующий экссудативный средний отит (симптомы не разрешаются в течение **3 месяцев**), резистентный к консервативному лечению и подтверждённый тимпанометрией;
3. рецидивирующие острые средние отиты или острые синуситы (**3 эпизода и более за 6 месяцев** или **4 и более за 12 месяцев**) после исключения других причин, прежде всего иммунодефицита, и при неэффективности медикаментозной профилактики;
4. хронический синусит с выраженными симптомами или частыми обострениями при неэффективности **1–2 курсов** консервативного лечения;
5. стойкое затруднение носового дыхания без других причин, ухудшающее качество жизни или ведущее к деформации лицевого скелета (цефалометрия, заключение ортодонта или челюстно-лицевого хирурга);
6. заключение других специалистов об аденотомии как этапе лечения сопутствующего заболевания (например, перед кардиохирургическим вмешательством).

Ориентир при объективной оценке нарушений сна: индекс апноэ-гипопноэ.

1. **5–15**: среднетяжёлая форма;
2. **более 15**: тяжёлая форма.

Детям аденотомию предпочтительно выполнять под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

4.3 Тонзиллотомия

Тонзиллотомия детям с гипертрофией нёбных миндалин: уменьшение размеров миндалин.

Показание

1. частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, в ряде случаев дневная сонливость и вялость); ориентир: индекс апноэ-гипопноэ, как при аденотомии.

1. выбор операции: при одновременных показаниях к тонзиллотомии и к тонзиллэктомии предпочтение отдаётся тонзиллэктомии;
2. условия: тонзиллотомию предпочтительно выполнять под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

4.4 Аденотомия с тонзиллотомией

Сочетанная гипертрофия аденоидов и нёбных миндалин: аденотомия с тонзиллотомией по показаниям к аденотомии.

Такое вмешательство проводится только под общим обезболиванием с обязательным визуальным контролем операционного поля; в раннем послеоперационном периоде пациент находится под наблюдением в ЛОР-отделении стационара.

4.5 Тонзиллэктомия у взрослых

Взрослые с гипертрофией нёбных миндалин и синдромом обструктивного апноэ сна: тонзиллэктомия при отсутствии противопоказаний.

> Для рекомендации о тонзиллэктомии у взрослых не указаны ни уровень убедительности рекомендаций, ни уровень достоверности доказательств. Кроме того, в разделах о госпитализации, послеоперационном обезболивании и реабилитации речь идёт только об аденотомии и тонзиллотомии, тонзиллэктомия у взрослых не упоминается.

4.6 Консервативное лечение аденоидита

Консервативное лечение детей с гипертрофией аденоидов: только при признаках аденоидита.

Признаки аденоидита

1. продуктивный кашель вследствие постназального затёка;
2. выделения из носа;
3. периодическое затруднение носового дыхания.

У детей **младше 7–9 лет** без значимого влияния на сон, приём пищи и дневную активность и без осложнений (например, средних отитов): наблюдение.

1. Промывание (орошение) полости носа всем пациентам с аденоидитом.
    1. 1–2 раза в день изотоническими или гипертоническими (1,5–3%) солевыми растворами на основе морской воды;
    2. облегчает туалет полости носа, уменьшает симптомы, улучшает условия для местных препаратов;
    3. детям дошкольного возраста промывание большими объёмами не рекомендуется: высокий риск средних отитов.
2. Местные антибактериальные препараты по специальным показаниям.

    Показания

    1. слизисто-гнойные выделения из носа и по задней стенке глотки в течение всего дня;
    2. отсутствие улучшения **за 7–10 дней** противовоспалительной терапии.

    Препараты (курс до 7 дней)

    1. назальный спрей фрамицетина;
    2. дексаметазон + неомицин + полимиксин B + фенилэфрин: детям **старше 2,5 года**;
    3. тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат: раствор для ингаляций.

    Введение в полость носа растворов антибиотиков, предназначенных для парентерального, внутриконъюнктивального или ушного применения, не рекомендуется: они не предназначены для полости носа и могут нарушать мукоцилиарный транспорт.
3. Карбоцистеин и другие мукорегулирующие препараты пациентам **старше 2 лет**.
    1. карбоцистеин в форме сиропа, в том числе карбоцистеина лизина моногидрат, курсом **от 1 до 3 месяцев**;
    2. уменьшает постназальный затёк и повышает вероятность разрешения сопутствующего экссудативного среднего отита;
    3. при монотерапии отличие от выжидательной тактики заметно лишь к 2–3-й неделе;
    4. при одновременном применении с интраназальным #мометазоном есть данные о синергизме противовоспалительного эффекта и более быстром купировании симптомов;
    5. другие муколитики, в том числе местные, одновременно не назначают: усиливают затёк.
4. #Мометазон назальный спрей по 50 мкг в каждый носовой ход 1 раз в сутки, **1–3 месяца**: детям **старше 2 лет** при сопутствующем аллергическом рините.

    Ни гипертрофия аденоидов, ни аденоидит, ни назофарингит не зарегистрированы в России в качестве показания ни для одного топического глюкокортикостероида; пометка off-label (в КР — знак #) обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.

Не рекомендуются

Масла, в первую очередь масло туи, при гипертрофии аденоидов и аденоидите не применяются: их эффективность не доказана, а в полости носа они угнетают функцию ресничек мерцательного эпителия, нарушают эвакуацию секрета и повышают риск бактериальной инфекции.

Ежедневное промывание полости носа растворами антисептиков не рекомендуется: эффективность не доказана, нарушается мукоцилиарный транспорт, возможны местные дисбиотические изменения.

4.7 Послеоперационное обезболивание

После аденотомии и (или) тонзиллотомии: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол.

Показания к обезболиванию

1. жалобы на боль;
2. отказ от еды и питья;
3. повторная рвота и тошнота.

Препарат	Доза у детей
Ибупрофен	8–10 мг/кг на приём, не более 30 мг/кг в сутки, внутрь в лекарственной форме, соответствующей возрасту (таблетки, покрытые оболочкой, — с 6 лет); детям младшего возраста — ректальные суппозитории.
Кетопрофен	С 6 лет — гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь (кетопрофена лизиновая соль), 40 мг на приём до 3 раз в день.
Парацетамол	10–15 мг/кг на приём, не более 60 мг/кг в сутки, в любой лекарственной форме, соответствующей возрасту. При невозможности приёма внутрь и отсутствии суппозиториев — парентерально 15 мг/кг на введение.

4.8 Послеоперационное ведение

Осмотр оториноларинголога после аденотомии и (или) тонзиллотомии: перед выпиской и амбулаторно **через 7–14 дней** после выписки.

Охранительный режим **5–7 дней** после операции.

1. ограничение контактов: не посещать детский коллектив и людные места;
2. ограничение физической нагрузки;
3. исключение перегревания, особенно головы и шеи, в том числе горячей пищи и питья.

Дисфония **более месяца** после операции: направление к логопеду-дефектологу.

Симптомы обструктивных нарушений сна **более 6–8 недель** после операции: направление к специалисту по расстройствам сна.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Специфическая профилактика гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин отсутствует. Поскольку важную роль играют респираторные вирусы, следует соблюдать общие правила профилактики острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Ряд лекарственных препаратов может применяться для плановой и экстренной профилактики аденоидита у детей.

Детям **старше 1 года** из групп риска по респираторным инфекциям рекомендованы стандартизированные растительные препараты для приёма внутрь из группы прочих антисептиков для профилактики эпизодов ОРВИ, а также для сокращения длительности и уменьшения тяжести последующих эпизодов аденоидита.

К ним относятся препараты, содержащие корень алтея, цветки ромашки, хвощ, листья грецкого ореха, тысячелистник, кору дуба и одуванчик лекарственный. Они назначаются также для лечения аденоидита при появлении симптомов ОРВИ в качестве монотерапии или в комплексе.

Детям **старше 3 лет** при появлении симптомов острого назофарингита применяют комбинированный препарат лизоцим + пиридоксин для сокращения длительности и уменьшения тяжести последующего аденоидита.

Детям из групп риска по респираторным инфекциям: лизаты бактерий для сокращения длительности и тяжести эпизодов аденоидита и осложнений.

Плановая профилактика курсами по инструкции **2–3 раза в год**, пероральные и местные формы.

Для профилактики аденоидитов и их осложнений у детей может рассматриваться применение местных пробиотиков на основе бактерий нормальной микрофлоры глотки.

Обратиться к врачу, если после простуды **2 недели и более** сохраняются:

1. заложенность носа;
2. храп;
3. снижение слуха;
4. кашель (при исключённой патологии нижних дыхательных путей).

5.2 Показания к госпитализации и выписке

Показание к госпитализации

1. плановая аденотомия и (или) тонзиллотомия при наличии показаний и отсутствии противопоказаний.

Лечение аденоидита проводится амбулаторно или в консультативно-диагностическом отделении.

Выписка после операции

1. удовлетворительное общее состояние;
2. отсутствие осложнений.

5.3 Факторы, влияющие на исход лечения

Влияют на исход операции

1. хронические соматические заболевания: возможно обострение в раннем послеоперационном периоде;
2. аллергический ринит: выше вероятность неполного регресса назальных симптомов (передней и задней ринореи, в меньшей степени заложенности);
3. ожирение: выше вероятность сохранения обструктивных нарушений сна;
4. гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: выше вероятность сохранения назальных симптомов и риск инфекционных осложнений.

При гипертрофии нёбных миндалин медикаментозное лечение аденоидита крайне малоэффективно в отношении обструктивных нарушений сна.

При наличии у ребёнка сопутствующего заболевания, способного повлиять на результат операции, врач должен проинформировать об этом пациента или родителей до операции.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	662_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Рекомендация о тонзиллэктомии взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и СОАС дана без уровня убедительности рекомендаций и уровня достоверности доказательств, а в разделах о госпитализации, обезболивании и реабилитации упоминаются только аденотомия и тонзиллотомия.
- Для хронического аденоидита в разделе 1.4 предложены два кода: J31.1 («как возможный вариант кодирования») и J35.8 («например, аденоидит»).
- В комментарии к ибупрофену фраза о суппозиториях оборвана («ректальные суппозитории (у детей младше) 2 лет»), поэтому возрастная граница неоднозначна.

Клинические рекомендации

Головная боль напряжения

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**G44** — Другие синдромы головной боли **G44.2** — Головная боль напряженного типа **G44.3** — Хроническая посттравматическая головная боль **G44.4** — Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках **G44.8** — Другой уточненный синдром головной боли **G90.8** — Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"; Межрегиональная общественная организация "Российское общество по изучению головной боли"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/162_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Головная боль напряжения (ГБН) — первичная головная боль: двусторонняя, давящая или стягивающая, слабой или умеренной интенсивности, длительностью **от 30 минут до нескольких суток**; физическая активность её не усиливает, тошноты нет.
- Диагноз клинический — по критериям МКГБ-3; дополнительные исследования при типичной ГБН не нужны. При «сигналах опасности» показаны МРТ головного мозга и консультации, в том числе оториноларинголога.
- Для купирования эпизодов — ибупрофен, кетопрофен, ацетилсалициловая кислота, напроксен; НПВП применяют при эпизодах **не чаще 2 раз в неделю**. При частой эпизодической и хронической ГБН проводится профилактика, препарат первого выбора — #амитриптилин.
- Злоупотребление обезболивающими — ведущий фактор хронизации. Безопасный режим — **не более 2 дней в неделю (8 дней в месяц)**; при лекарственно-индуцированной головной боли препарат злоупотребления ограничивают или отменяют.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

ГБН — одна из наиболее распространённых форм первичной головной боли: двусторонняя боль давящего или стягивающего характера, слабой или умеренной интенсивности, продолжительностью **от 30 минут до нескольких суток**.

Боль не усиливается при обычной физической активности и не сопровождается тошнотой; возможны снижение аппетита, фото- или фонофобия.

2.2 Этиология и эпидемиология

В происхождении ГБН участвуют периферические механизмы (болезненное напряжение мышц головы и шеи, гипоксия мышц, выделение провоспалительных медиаторов) и центральные — снижение активности антиноцицептивной системы ствола мозга с формированием центральной сенситизации. При эпизодической ГБН ведущую роль играют периферические факторы, при хронической — центральные; депрессия и тревога способствуют хронизации.

Распространённость ГБН на протяжении жизни — 78%, за год в России — около 31%. Чаще всего встречается эпизодическая форма (1 день с болью в месяц и менее), не требующая лечения; у 2–3% — хроническая. Средний возраст начала — 25–30 лет.

2.3 Классификация

Формы ГБН (МКГБ-3, 2018)

1. нечастая эпизодическая;
2. частая эпизодическая;
3. хроническая;
4. возможная ГБН — нечастая эпизодическая, частая эпизодическая, хроническая.

Каждая форма подразделяется на сочетающуюся и не сочетающуюся с напряжением перикраниальных мышц. ГБН относится к первичным цефалгиям, не связанным с органическим поражением головного мозга, сосудов и других структур головы и шеи.

2.4 Клиническая картина

Характерные признаки

1. повторяющиеся эпизоды двусторонней диффузной сжимающей непульсирующей боли по типу «каски» или «обруча»;
2. локализация в лобной, височной, теменной, возможно затылочной области или во всей голове;
3. слабая или умеренная интенсивность — 4–7 баллов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ);
4. прогулка и лёгкая нагрузка могут облегчить боль;
5. возможны лёгкая тошнота и снижение аппетита; фото- и фонофобия редки и, в отличие от мигрени, не развиваются одновременно.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагностика клиническая — по соответствию картины критериям МКГБ-3 на приёме невролога.

Диагностические критерии нечастой эпизодической ГБН

1. A. Не менее 10 эпизодов с частотой **не более 1 дня в месяц** (не более 12 дней в году), отвечающих пунктам B–D.
2. B. Продолжительность **от 30 минут до 7 дней**.
3. C. Не менее 2 из 4 характеристик: двусторонняя локализация; давящий, сжимающий, не пульсирующий характер; лёгкая или умеренная интенсивность; боль не усиливается при обычной физической активности.
4. D. Оба признака: отсутствие тошноты или рвоты; только фото- или только фонофобия.
5. E. Другой диагноз МКГБ-3 не подходит в большей степени.

Частая эпизодическая ГБН: не менее 10 эпизодов **от 1 до 14 дней в месяц** (более 12 дней в среднем более 3 месяцев и менее 180 дней в году); остальные критерии те же.

Хроническая ГБН: боль **более 15 дней в месяц** в среднем более 3 месяцев (более 180 дней в году), продолжается несколько часов или постоянно; допускаются фото-, фонофобия или лёгкая тошнота, но не умеренная или сильная тошнота и рвота.

При повышенной болезненности перикраниальных мышц при пальпации форма уточняется как «сочетающаяся с напряжением перикраниальных мышц», при её отсутствии — «не сочетающаяся».

3.2 Лекарственно-индуцированная головная боль

ГБН, особенно хроническая, может сочетаться с избыточным применением обезболивающих; лекарственный абузус рассматривается как один из ведущих факторов хронизации.

Обобщённые критерии ЛИГБ (МКГБ-3)

1. A. Головная боль **более 15 дней в месяц** у пациента с исходной первичной головной болью.
2. B. Регулярное злоупотребление **более 3 месяцев** одним или более препаратами для купирования боли.
3. C. Боль не соответствует в большей степени другому диагнозу МКГБ-3.

Формы ЛИГБ по числу дней приёма

Препараты злоупотребления	Число дней с приёмом в месяц (3 месяца и более)
парацетамол, НПВП, ацетилсалициловая кислота, другие анальгетики и антипиретики	15 и более
эрготаминсодержащие препараты, триптаны	10 и более
опиоиды, анальгетики с компонентами разных классов, комбинации нескольких классов, другие препараты	10 и более

У пациентов с частой эпизодической и хронической ГБН проводится клиническая диагностика ЛИГБ по числу дней с приёмом обезболивающих и типу препаратов (дневник головной боли).

ЛИГБ проявляется диффузной монотонной, чаще утренней или ночной болью, нарастающей с прекращением действия принятого препарата. Наибольший риск — у препаратов с кодеином, барбитуратами и кофеином.

При выявлении ЛИГБ выставляются два диагноза: ГБН и ЛИГБ — для выбора тактики лечения.

3.3 Жалобы и анамнез

Эпизоды боли продолжаются от 30 минут до нескольких дней; при хронической ГБН боль может присутствовать весь день с периодическими усилениями. Эпизоды провоцируются психическим или позным напряжением головы и шеи и облегчаются при психологической релаксации и расслаблении перикраниальных мышц.

У пациентов с ГБН выявляют коморбидные нарушения: они поддерживают мышечное напряжение, способствуют хронизации и требуют коррекции.

Наиболее частые коморбидные нарушения

1. депрессия;
2. тревожные расстройства, в том числе панические атаки;
3. соматоформные и сенесто-ипохондрические расстройства;
4. нарушение ночного сна;
5. другие болевые синдромы, в том числе фибромиалгия.

3.4 Физикальное обследование

Всем пациентам исследуется неврологический статус для исключения органической симптоматики; при типичной ГБН патологии нет.

Возможные находки

1. снижение настроения, тревожность;
2. вегетативные нарушения: гипервентиляция, ладонный гипергидроз, симптом Хвостека I–III степени;
3. неспособность к психологическому и мышечному расслаблению.

Всем пациентам проводится пальпация перикраниальных мышц мелкими вращательными движениями II и III пальцами с обеих сторон.

Области пальпации

1. височные и жевательные мышцы;
2. грудино-ключично-сосцевидные и трапециевидные мышцы;
3. задняя группа мышц шеи (ремённые, нижние косые).

При болезненном напряжении одной или более групп диагноз уточняется: например, «ХГБН с напряжением перикраниальных мышц».

3.5 Лабораторные исследования

При типичной клинической картине без неврологических нарушений лабораторные исследования не рекомендуются. При атипичной картине или «сигналах опасности» выполняются общий (клинический) анализ крови, исследования общевоспалительных реакций и коагулограмма.

3.6 Инструментальные исследования и консультации

При типичной картине и нормальном неврологическом статусе инструментальные исследования и консультации специалистов не рекомендуются. Атипичным считается течение при невыполнении 2 и более критериев МКГБ-3.

При атипичной картине или «сигналах опасности»

1. МРТ головного мозга, МР-ангиография, МР-венография; при невозможности — КТ головного мозга и КТ-ангиография;
2. консультация офтальмолога;
3. консультация оториноларинголога;
4. консультация психотерапевта.

«Сигналы опасности»

1. боль, впервые возникшая после 50 лет, или изменившая течение;
2. «громоподобная» боль, нарастающая до 10 баллов по ВАШ **за 1–2 секунды**;
3. строго односторонняя боль;
4. прогрессивно ухудшающаяся боль без ремиссий;
5. внезапная, необычная для пациента боль;
6. атипичная мигренозная аура: необычные нарушения и/или продолжительность **более 1 часа**;
7. изменения сознания или психические нарушения;
8. очаговые неврологические знаки и симптомы системного заболевания: лихорадка, сыпь, ригидность шеи, артралгии, миалгии;
9. признаки внутричерепной гипертензии: усиление боли при кашле, натуживании, напряжении;
10. отёк диска зрительного нерва;
11. ВИЧ-инфекция, онкологическое, эндокринное, системное заболевание или травма головы в анамнезе;
12. дебют во время беременности или в послеродовом периоде;
13. неэффективность адекватного лечения.

3.7 Дневник головной боли

Дневник **в течение 1–3 месяцев** позволяет установить число дней с болью и с приёмом обезболивающих, отличить приступ мигрени от эпизода ГБН и выявить лекарственный абузус.

3.8 Дифференциальная диагностика

При нетипичном течении ГБН дифференцируют

1. с мигренью;
2. с головной болью при интракраниальной венозной дисфункции;
3. с головной болью при изменении ликворного давления;
4. с миофасциальной дисфункцией перикраниальных мышц;
5. с цервикогенной головной болью.

Применяются МРТ головного мозга, МР-венография, при необходимости — консультация офтальмолога.

Хроническую ГБН дифференцируют с хронической мигренью и новой ежедневной персистирующей головной болью.

При хронической мигрени, в отличие от ГБН, в начале заболевания были типичные приступы эпизодической мигрени и характерные для неё признаки: наследственный анамнез, типичные триггеры, облегчение во время беременности. Сочетающиеся формы головной боли вносятся в диагноз.

Течение ухудшается при неверных «органических» диагнозах вместо ГБН: дисциркуляторная энцефалопатия, остеохондроз шейного отдела позвоночника, вегетососудистая дистония, гипертензионно-гидроцефальный синдром. Их причина — трактовка неспецифических изменений УЗДГ, МРТ, рентгенографии как органических; итогом становятся психостимуляторы и ноотропы без доказанной эффективности вместо антидепрессантов.

---

4. Лечение

Ведение пациентов включает поведенческую терапию, купирование болевых эпизодов и профилактическое (курсовое) лечение. Цели — снижение частоты и интенсивности эпизодов и повышение качества жизни.

4.1 Поведенческая терапия

Основные положения

1. разъяснение доброкачественной природы ГБН и разубеждение в органической причине;
2. обоснование нецелесообразности дополнительных исследований, кроме подозрения на симптоматическую боль;
3. роль провокаторов: эмоционального и мышечного напряжения, тревоги, депрессии;
4. необходимость обучения психологическому и мышечному расслаблению;
5. роль факторов хронизации; при злоупотреблении обезболивающими — необходимость отказа от них;
6. цели лечения, механизм действия профилактических препаратов, польза немедикаментозных методов.

4.2 Купирование эпизодов

Препараты для купирования эпизода ГБН

Препарат	Разовая доза	УУР
ибупрофен — препарат выбора	400 мг	A
кетопрофен — препарат выбора	25 мг	A

Препарат	Разовая доза	УУР
ацетилсалициловая кислота — препарат выбора	500–1000 мг	A
напроксен — препарат выбора	550 мг (часто 500 мг однократно)	B
#диклофенак — препарат выбора, порошок для раствора внутрь	12,5–25 мг	B
парацетамол	1000 мг	C
анальгетики и антипиретики с кофеином	—	B

Для купирования эпизодов ГБН не рекомендуются

1. **препараты с метамизолом натрия** — высокий риск агранулоцитоза
2. **триптаны, опиоидные анальгетики, миорелаксанты, анальгетики с кодеином или барбитуратами** — высокий риск ЛИГБ

Принципы назначения обезболивающих

1. НПВП эффективнее ацетилсалициловой кислоты, она — эффективнее парацетамола;
2. растворимые формы ибупрофена, кетопрофена, ацетилсалициловой кислоты действуют быстрее;
3. НПВП применяют при эпизодической ГБН с частотой **не более 2 раз в неделю (до 10 дней в месяц)**, чаще — эффект снижается и возникает риск ЛИГБ;
4. учитывают действие НПВП на желудочно-кишечный тракт и риск кровотечений;
5. комбинация ацетилсалициловой кислоты, кофеина и парацетамола эффективнее монотерапии, но при приёме **более 8 дней в месяц** возникает риск ЛИГБ.

4.3 Профилактическое лечение

Профилактическая терапия показана при частой эпизодической и хронической формах для уменьшения числа дней с болью в месяц.

Общие правила

1. разъяснить пациенту, что антидепрессанты обладают и противоболевым действием;
2. дозу повышают медленно для минимизации побочных эффектов;
3. выбранный препарат принимают в переносимой дозе **6–12 месяцев**;
4. при отсутствии эффекта **в течение 3 месяцев** препарат меняют или используют комбинацию;
5. общая длительность — **3–6 месяцев** при эпизодической и **до 12 месяцев** при хронической ГБН.

Препаратом первого выбора является #амитриптилин; большую часть дозы принимают за 1–2 часа до сна.

1. начальная доза: 5–10 мг в сутки
2. титрация: на 5–10 мг **каждую неделю** до эффекта или нежелательных явлений
3. средняя эффективная доза: 50–75 мг в сутки (от 25 до 150 мг)

При противопоказаниях, плохой переносимости или недостаточной эффективности #амитриптилина применяются препараты второго выбора; эффективность других антидепрессантов, в том числе СИОЗС, при ГБН недостаточно доказана.

1. #кломипрамин: 75–150 мг/сут внутрь
2. #венлафаксин: 150 мг/сут
3. #миртазапин: 30 мг/сут
4. #габапентин: 2400 мг/сут — при хронической ГБН и неэффективности или непереносимости антидепрессантов

При выраженной дисфункции перикраниальных мышц в качестве дополнительной терапии применяют миорелаксанты; длительность — **не более 2 месяцев** (в среднем 3–4 недели). Сочетание с антидепрессантом повышает приверженность лечению.

1. #тизанидин: 2 мг 3 раза в сутки, при необходимости до 4–6 мг 3 раза в сутки
2. #толперизон: 450 мг в сутки внутрь

Профилактическое лечение эффективно, если число дней с болью в месяц **через 3 месяца** сокращается **на 50% и более**.

Дополнительные критерии — уменьшение приёма обезболивающих и коморбидных нарушений, повышение работоспособности и качества жизни.

Без улучшения пациента направляют в специализированное болевое отделение или центр лечения головной боли.

4.4 Лечение ГБН с лекарственно-индуцированной головной болью

Лечение включает поведенческую терапию, отмену препаратов злоупотребления, купирование головной боли отмены (детоксикацию) и профилактическое лечение ГБН.

Частая эпизодическая ГБН с 8 и более днями боли и 8–10 днями приёма обезболивающих в месяц — группа риска ЛИГБ. Пациентам разъясняют безопасный режим: **не чаще 2 дней в неделю, не более 8 дней в месяц**.

При лекарственном абузусе препарат злоупотребления существенно ограничивают или отменяют: приём любых обезболивающих — **не более 2 дней в неделю (8 в месяц)**. Отмена анальгетиков проводится амбулаторно, опиоидов и анальгетиков в комбинации с психотропными средствами — в стационаре или дневном стационаре.

В период отмены для лечения «рикошетной» головной боли и других проявлений синдрома отмены проводят детоксикацию **в первые 2 недели**; препараты выбирают по клиническим проявлениям.

1. #преднизолон внутрь: 100 мг 5 дней или 60 мг 2 дня, 40 мг 2 дня, 20 мг 4 дня
1. #метилпреднизолон: 125 мг в 250 мл раствора натрия хлорида внутривенно капельно 1 раз в сутки 5 дней вместе с #диазепамом 10 мг и эзомепразолом 40 мг
1. #целекоксиб: 400 мг/сут (200 мг 2 раза) 5 дней, затем снижение на 100 мг каждые 5 дней до отмены

Можно применять обезболивающие тех классов, которыми пациент не злоупотреблял.

1. метоклопрамид при выраженной тошноте и рвоте: 10 мг 1 раз в сутки внутрь или внутримышечно 5–7 дней

Наряду с лечением ЛИГБ проводится профилактическая терапия ГБН — предпочтительно одновременно с отменой препарата злоупотребления; препарат первого выбора — #амитриптилин 50–150 мг в сутки.

При трудностях ведения пациента врачи общей практики, терапевты и неврологи направляют его к специалисту по головной боли или в специализированный центр.

4.5 Немедикаментозное лечение

Для повышения эффективности профилактики, особенно при хронической ГБН, фармакотерапию сочетают с нелекарственными методами.

Нелекарственные методы

1. **биологическая обратная связь по электромиографии мышц скальпа и шеи** — УУР А
2. **когнитивно-поведенческая терапия** — УУР А
3. **постизометрическая релаксация** — УУР А
4. **лечебная физкультура** — УУР В
5. **рефлексотерапия** — УУР В

Серия из 8–15 сеансов биологической обратной связи существенно снижает частоту эпизодов и уровень тревоги.

Как правило, рекомендуется не менее 10 сеансов лечебной физкультуры.

При триггерных точках в напряжённых перикраниальных мышцах и мышцах шеи может применяться их пункция сухой иглой.

Диетотерапия для профилактики ГБН не рекомендуется.

4.6 Медицинская реабилитация

Реабилитационные мероприятия при ГБН не разработаны.

В дополнение к нелекарственным методам

1. медицинский массаж шеи, воротниковой зоны и спины;
2. релаксационный тренинг, аутогенная тренировка;
3. аэробные физические упражнения, кинезиотерапия;
4. остеопатия, спинальные манипуляции, мануальная терапия.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Пациентам разъясняют роль провоцирующих факторов (прежде всего стресса и позного мышечного напряжения) и факторов хронизации: лекарственного абузуса, хронического стресса, депрессии, тревоги, перенапряжения перикраниальных мышц.

Рекомендуют избегать длительной работы в вынужденной позе, конфликтных и стрессовых ситуаций, избыточного приёма обезболивающих; обучают психологическому и мышечному расслаблению.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация в неврологическое отделение

1. головная боль с изменением сознания;
2. головная боль с лихорадкой и менингеальными симптомами;
3. нарастающая очаговая неврологическая симптоматика;
4. нарастающая общемозговая симптоматика;
5. «громоподобная» головная боль.

Плановая госпитализация

1. прогрессирующая головная боль;
2. некупируемая головная боль;
3. головная боль при избыточном потреблении опиоидов, спазмолитиков, психотропных средств и анальгетиков в комбинации.

Критерии выписки

1. купирование головной боли;
2. уменьшение боли **до 3–4 баллов по ВАШ**;
3. успешная замена препарата злоупотребления на адекватную терапию.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Головная боль напряжения (ГБН)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	162_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Российское общество по изучению головной боли; Союз реабилитологов России
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Граница хронической формы: в критериях (табл. 3g) хроническая ГБН — «более 15 дней в месяц», частая эпизодическая — «от 1 до 14 дней», а в «Терминах и определениях» хронические головные боли — «15 и более дней в месяц»; 15 дней в месяц по критериям не относится ни к одной форме.
- Рекомендация о профилактической терапии ГБН (3.3) содержит вставку из КР по мигрени: «профилактическое лечение пациентам с М, у которых наблюдается 3 и более тяжёлых дезадаптирующих приступа… или ≥ 8 дней с ГБ в месяц, а также пациентам с пролонгированной аурой»; на странице приведено показание для ГБН — частая эпизодическая и хроническая форма.

Клинические рекомендации

Головная боль напряжения у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**G44** — Другие синдромы головной боли **G44.2** — Головная боль напряженного типа **G44.3** — Хроническая посттравматическая головная боль **G44.8** — Другой уточненный синдром головной боли **G90.8** — Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/810_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Головная боль напряжения — первичная головная боль: двусторонняя, лёгкой или умеренной интенсивности, сжимающая или давящая, длительностью **от 30 минут до нескольких дней, но менее недели**; не усиливается при обычной физической нагрузке и не сопровождается рвотой.
- Диагноз устанавливается клинически по критериям МКГБ-3. Лабораторные и инструментальные исследования для диагностики не рекомендуются; МРТ или КТ головного мозга показаны только при «сигналах опасности».
- Головную боль напряжения дифференцируют с мигренью, реже — с вторичной головной болью, в том числе при хроническом риносинусите. При подозрении на симптоматическую головную боль показаны консультации специалистов, среди которых чаще всего — офтальмолог и оториноларинголог.
- Для купирования приступа применяют парацетамол или ибупрофен, если приступы возникают **не чаще 2 раз в неделю**. Обезболивающие **более 2 (максимум 3) раз в неделю** не рекомендуются из-за риска лекарственного абузуса; при частой эпизодической и хронической форме проводится профилактическая терапия.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Головная боль напряжения (ГБН) — одна из наиболее распространённых форм первичной головной боли. Проявляется продолжительными приступами двусторонней головной боли лёгкой или умеренной интенсивности, сжимающего, давящего или ноющего характера.

Длительность приступа — **от 30 минут до нескольких дней**, но менее недели. Возможна свето- или звукобоязнь, но не обе сразу; боль не усиливается при повседневной физической активности и не сопровождается рвотой.

2.2 Этиология и эпидемиология

В патогенезе задействованы периферические (мышечный спазм) и центральные механизмы боли (центральная сенситизация и дезингибиция); начальные звенья связаны с напряжением перикраниальных мышц в ответ на эмоциональный стресс. У детей незрелость механизмов психологической защиты приводит к проявлению заболевания при незначительных, с точки зрения взрослых, стрессовых факторах.

Предрасполагающие факторы

1. высокий уровень тревожности;
2. значимая психотравмирующая ситуация, трудности адаптации к новой обстановке;
3. неспособность к психологическому и мышечному расслаблению;
4. расстройства сна;
5. психическое переутомление, зрительные нагрузки, в том числе за компьютером;
6. статическое (познотоническое) напряжение — длительное вынужденное положение головы и шеи.

ГБН — наиболее распространённая форма первичной головной боли; средний возраст начала — 7 лет. Ею страдают 5–20,5% детей и подростков, у взрослых распространённость достигает 30–80%.

2.3 Классификация

Варианты по частоте приступов (МКГБ-3)

1. **нечастая эпизодическая** — **не более 1 раза в месяц (не более 12 дней в году)** при не менее чем 10 перенесённых эпизодах
2. **частая эпизодическая** — **от 1 до 15 раз в месяц** в среднем более 3 месяцев (12–180 дней в году)
3. **хроническая** — **15 дней и более в месяц** в среднем более 3 месяцев (более 180 дней в году)

Каждый вариант может наблюдаться без напряжения и с напряжением перикраниальных мышц.

2.4 Клиническая картина

Боль постоянная, давящая.

Локализация

1. в большинстве случаев — лоб и виски с иррадиацией в затылочную область и заднюю поверхность шеи;
2. затем боль становится диффузной: ощущение сжатия головы обручем, симптом «шлема» или «каски»;
3. наибольшая интенсивность в течение дня может перемещаться с одной половины головы на другую; стойкая односторонняя боль, как правило, связана с повышенной чувствительностью перикраниальных мышц.

Как правило, боль появляется днём (после 2–3-го урока) или во второй половине дня и продолжается до вечера; повседневная нагрузка её не усиливает. Транзиторные неврологические симптомы не характерны.

Течение может быть длительным, многолетним, возможна хронизация. При своевременной диагностике и адекватной терапии у многих детей достигается клиническая ремиссия.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз ГБН основывается на клинических проявлениях в соответствии с критериями МКГБ-3 (2018).

Диагностические критерии нечастой эпизодической ГБН

1. A. Не менее 10 эпизодов с частотой **не более 1 дня в месяц** (не более 12 дней в году), отвечающих пунктам B–D.
2. B. Длительность **от 30 минут до 7 суток** (у детей может быть до 30 минут).
3. C. Не менее 2 характеристик: двусторонняя локализация; стягивающий, давящий, не пульсирующий характер; лёгкая или умеренная интенсивность; боль не усиливается при обычной физической нагрузке.
4. D. Оба признака: отсутствие тошноты или рвоты (возможно снижение аппетита); только фотофобия или только фонофобия.
5. E. Боль не соответствует в большей степени другому диагнозу МКГБ-3.

При повышенной болезненности перикраниальных мышц при пальпации устанавливается диагноз ГБН, сочетающейся с напряжением перикраниальных мышц.

Частая эпизодическая ГБН: не менее 10 эпизодов **от 1 до 14 дней в месяц** (более 12 дней в среднем более 3 месяцев и менее 180 дней в году); критерии B–E те же.

Хроническая ГБН: головная боль **15 и более дней в месяц** в среднем более 3 месяцев (более 180 дней в году); критерии B–E те же.

3.2 Жалобы и анамнез

При сборе анамнеза уточняют

1. время дебюта, частоту, провоцирующие факторы;
2. длительность и локализацию боли;
3. характер боли;
4. сопровождающие симптомы.

Характерные признаки ГБН

1. повторяющиеся эпизоды двусторонней диффузной сжимающей или давящей, не пульсирующей боли по типу «каски» или «обруча»;
2. локализация в лобной, височной, теменной, возможно затылочной области или во всей голове;
3. слабая или умеренная интенсивность — 4–7 баллов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ);
4. прогулка на свежем воздухе может облегчить боль;
5. возможны лёгкая тошнота и снижение аппетита; фото- и фонофобия редки и не развиваются одновременно.

Интенсивность боли в приступе оценивают по ВАШ — у детей совместно с родителями.

3.3 Физикальное обследование

Детям с головной болью проводится тщательный общеклинический и неврологический осмотр для исключения симптоматического характера боли. При ГБН общемозговые и очаговые симптомы не выявляются, но при пальпации может определяться повышенная болезненность перикраниальных мышц.

Пальпация для выявления напряжения мышц и «триггерных» точек

1. височная, лобная, затылочная области;
2. мышцы задней поверхности шеи;
3. трапециевидные и грудино-ключично-сосцевидные мышцы.

При подозрении на симптоматическую природу головной боли показаны консультации специалистов.

Чаще всего

1. офтальмолог;
2. оториноларинголог;
3. травматолог-ортопед;
4. эндокринолог;
5. нейрохирург.

При выраженных эмоционально-личностных, соматоформных и сенесто-ипохондрических расстройствах показана консультация психиатра: они учащают головную боль и снижают качество жизни.

Типичные коморбидные нарушения у детей с ГБН

1. тревожные и/или депрессивные расстройства;
2. нарушения поведения;
3. синдром дефицита внимания и гиперактивности;
4. астенический синдром;
5. нарушения сна;
6. другие болевые синдромы.

3.4 Лабораторные исследования

Лабораторные исследования для диагностики ГБН не рекомендуются: специфических изменений они не выявляют.

Показания к дополнительным исследованиям

1. сомнения в диагнозе первичной головной боли: нетипичные жалобы или течение, невыполнение более одного критерия;
2. выполнение критериев вторичной головной боли;
3. один или более «сигналов опасности»;
4. требование пациента или его родственников.

В этих случаях выполняются общий (клинический) анализ крови, исследования общевоспалительных реакций, коагулограмма, динамическое измерение артериального давления вне приступа и во время приступа.

3.5 Нейровизуализация

Инструментальные исследования для диагностики ГБН не рекомендуются; нейровизуализация при повторяющейся головной боли без изменений неврологического статуса и ЭЭГ нецелесообразны.

«Сигналы опасности» — показания к МРТ или КТ головного мозга

1. внезапная впервые возникшая интенсивная головная боль;
2. прогрессивно нарастающая интенсивность без ремиссий;
3. изменение характера хронической головной боли;
4. сочетание с очаговой симптоматикой, продолжающейся **более 1 часа**;
5. сочетание с нарушением сознания и расстройством поведения;
6. строго односторонняя боль, признаки внутричерепной гипертензии и системного заболевания.

Детям с головной болью показано исследование глазного дна для исключения отёка зрительного нерва и повышения внутричерепного давления; офтальмологическое обследование может включать остроту и поля зрения, выявление спазма аккомодации.

3.6 Дневник головной боли

Ведение дневника головной боли **в течение 1–3 месяцев** позволяет установить число дней с болью и с приёмом обезболивающих в месяц, отличить приступ мигрени от эпизода ГБН. При обращении в специализированные центры головной боли дневник обязателен.

3.7 Дифференциальная диагностика

ГБН дифференцируют с мигренью, реже — с вторичной головной болью: при изменении ликворного давления, цервикогенной, при хронических риносинуситах, при других неврологических заболеваниях.

Идиопатическая внутричерепная гипертензия

1. повышение внутричерепного давления при нормальных данных КТ или МРТ;
2. боль диффузная, с максимумом в лобной области, усиливается при кашле, чихании, наклоне головы вниз;
3. двоение и боль в глазах, шум в ушах;
4. отёк диска зрительного нерва и паралич VI черепного нерва.

Головная боль при хронических риносинуситах продолжительная и периодическая: максимум приходится на середину дня.

При фронтите боль постоянная и, как правило, интенсивная, особенно при затруднении оттока отделяемого. Она локализуется в лобной области с максимумом в области переносицы.

Боль усиливается

1. при давлении или постукивании по передней стенке лобной пазухи;
2. при физическом напряжении, кашле, чихании;
3. при поворотах головы, в положении лёжа на животе.

Дети часто жалуются на светобоязнь, слезотечение и обильные выделения из соответствующей половины носа, особенно утром при переходе в вертикальное положение. Диагноз подтверждается риноскопией и рентгенографией лобных пазух.

При подозрении на цервикогенную головную боль показаны рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, снимок атлантоокципитального сочленения или МРТ шеи. После травмы шейного отдела боль возникает после нагрузки на шею, локализуется в шее, затылочной области и области сосцевидных отростков, усиливается при движениях головой и пальпации; характерны вынужденное положение и ограничение подвижности головы.

Симптомы, требующие исключения неврологических заболеваний и соматической патологии

1. изменения уровня сознания: оглушённость, спутанность;
2. диффузная боль, прогрессивно нарастающая с каждым днём;
3. постоянная многомесячная боль, не поддающаяся терапии;
4. утренняя боль с многократной рвотой без тошноты;
5. зависимость интенсивности от положения головы и тела;
6. внезапная новая, необычная для пациента тяжёлая боль;
7. очаговые неврологические симптомы;
8. нарастание боли параллельно с повышением температуры, симптомы системного заболевания: лихорадка, артралгии, миалгии.

Исключают внутричерепные объёмные процессы (опухоль, абсцесс) и нейроинфекции (менингит, энцефалит).

---

4. Лечение

Лечение включает фармакотерапию и немедикаментозные методы; стратегия зависит от частоты приступов и коморбидных нарушений.

При эпизодической ГБН с частотой **более 2 приступов в неделю** предпочтительнее профилактическое лечение, чем купирование приступов.

При хронической ГБН обезболивающие сомнительно эффективны и повышают риск лекарственно индуцированной головной боли, поэтому основное значение имеет профилактическая терапия.

4.1 Купирование приступа

При нечастой и частой эпизодической ГБН с приступами **не чаще 2 раз в неделю** применяется парацетамол в самом начале приступа.

1. дети: 10–15 мг/кг на приём
2. повторно: **через 6–8 часов**

При приступах умеренной и высокой интенсивности **не чаще 2 раз в неделю** применяется ибупрофен в начале приступа; по обезболивающему эффекту и действию на ЖКТ и почки он сопоставим с парацетамолом, но не оказывает токсического действия на печень.

1. дети: 7,5 мг/кг на приём

Для купирования приступов умеренной и высокой интенсивности применяется кетопрофен (лизиновая соль, гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь).

1. дети **старше 6 лет**: 40 мг на приём, до 3 раз в сутки

При частых приступах не рекомендуется применять обезболивающие **более 2 (максимум 3) раз в неделю** из-за высокого риска лекарственного абузуса.

Для купирования ГБН у детей не рекомендуются

1. **метамизол натрия** — высокий риск агранулоцитоза
2. **салициловая кислота и её производные** — риск синдрома Рейе
3. **комбинированные анальгетики с кофеином, фенобарбиталом, эрготамином или кодеином** — высокий риск лекарственно индуцированной головной боли

4.2 Профилактическая терапия

Детям с частой эпизодической и хронической ГБН проводится профилактическая терапия для уменьшения числа дней с головной болью в месяц.

При выраженном отрицательном влиянии боли на повседневную активность применяется #амитриптилин внутрь. Перед назначением регистрируется ЭКГ; дневная сонливость часто возникает при дозе выше 30–40 мг в сутки, другие побочные эффекты — ортостатическая гипотензия и антихолинергические.

1. начальная доза: 5–10 мг (или 0,25 мг/кг) перед сном
2. повышение: на 0,25 мг/кг **каждые 2–3 недели** до 1 мг/кг/сут
3. длительность: **от 2 месяцев** при частой эпизодической, **4–6 месяцев** при хронической ГБН

При неэффективности #амитриптилина **в течение 2–3 месяцев** назначается фиксированная комбинация #магния и пиридоксина или #вальпроевая кислота. У девочек в пре- и пубертатном периоде учитывают возможные нежелательные эффекты вальпроевой кислоты со стороны эндокринной системы.

1. магний + пиридоксин: из расчёта магния пидолата 200–300 мг в сутки в 2 приёма внутрь (раствор)
2. вальпроевая кислота: внутрь с постепенным повышением дозы до 10–20 мг/кг/сут

4.3 Немедикаментозное лечение

При слабой интенсивности боли

1. прогулки на свежем воздухе;
2. физические упражнения умеренной интенсивности;
3. массаж волосистой части головы и шейно-воротниковой зоны;
4. тёплый душ;
5. сон.

Для повышения адаптационных возможностей ЦНС и уменьшения мышечно-тонического синдрома

1. когнитивно-поведенческая терапия;
2. постизометрическая мышечная релаксация;
3. дыхательный релаксационный тренинг;
4. биологическая обратная связь;
5. аутогенная тренировка.

Показаны занятия с психологом, психотерапевтом для выработки стратегии поведения в стрессовой ситуации и уменьшения тревожности.

Детям школьного возраста и подросткам проводится когнитивно-поведенческая терапия: её основа — выявление и устранение ситуации хронического стресса и разъяснение природы ГБН, в том числе роли эмоциональных факторов и перенапряжения перикраниальных мышц.

Необходимые компоненты

1. исключение провокаторов головной боли;
2. режим питания и гигиена сна;
3. рациональное распределение физических, умственных и психоэмоциональных нагрузок;
4. регулярные оздоровительные спортивные занятия;
5. обучение психологической и мышечной релаксации.

При напряжении перикраниальных мышц проводится курс биологической обратной связи по электромиографическому сигналу.

4.4 Лечение коморбидных нарушений

1. **тревожные расстройства и эмоциональные нарушения** — анксиолитики и антипсихотические средства
2. **тревожные и депрессивные расстройства** — антидепрессанты, разрешённые у детей и подростков: амитриптилин, сертралин внутрь 12,5–25 мг 1 раз в сутки, через неделю 50 мг/сут, курс 6–8 недель
3. **астенические нарушения** — #левокарнитин и #деанола ацеглумат
4. **неэффективность немедикаментозных методов и невозможность лечения амитриптилином** — ноотропные препараты с седативным действием — #гопантеновая кислота и #аминофенилмасляная кислота 15–20 мг/кг в день внутрь в 2–3 приёма при частой эпизодической и хронической ГБН

4.5 Оценка эффекта терапии

Эффективность профилактического лечения оценивают по уменьшению среднего числа приступов в месяц **на 50% и более**; исходную частоту определяют за **2 месяца** до начала лечения.

Дополнительные критерии

1. снижение интенсивности боли по 10-балльной ВАШ;
2. снижение влияния боли на повседневную активность по HIT-6;
3. уменьшение приёма обезболивающих;
4. уменьшение коморбидных нарушений: улучшение настроения, снижение тревоги, нормализация сна.

4.6 Медицинская реабилитация

Реабилитационные мероприятия у детей с ГБН не разработаны.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Детям и подросткам разъясняют роль провоцирующих факторов и необходимость их избегать: познотонического мышечного и избыточного эмоционального напряжения, стресса, нарушений сна.

5.2 Показания к госпитализации

Плановая госпитализация

1. прогрессирующая головная боль;
2. некупируемая головная боль;
3. подозрение на симптоматическую природу боли при «сигналах опасности».

Экстренная госпитализация

1. головная боль с изменением сознания;
2. головная боль с лихорадкой и менингеальными симптомами;
3. нарастающая очаговая неврологическая симптоматика;
4. нарастающая общемозговая симптоматика;
5. боль крайне высокой интенсивности — **10 баллов по ВАШ**.

Критерии выписки

1. купирование головной боли;
2. уменьшение боли **до 3–4 баллов по ВАШ**;
3. выяснение причины вторичной головной боли и выбор лечебного подхода.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Головная боль напряжения»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 15.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	`810_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Союз реабилитологов России
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Граница частой эпизодической и хронической формы: в классификации (1.5) частая эпизодическая ГБН — «от 1 до 15 раз в месяц», а хроническая — «15 дней и более»; в диагностических критериях (раздел 2) частая эпизодическая — «от 1 до 14 дней в месяц». От формы зависит длительность профилактического курса амитриптилина (от 2 месяцев или 4–6 месяцев).

Клинические рекомендации

Грибковый отит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B37.8** — Кандидоз других локализаций **B44.8** — Другие виды аспергиллеза **B49** — Микоз неуточненный **H60.8** — Другие наружные отиты **H62.2** — Наружный отит при микозах **H66.3** — Другие хронические гнойные средние отиты
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/304_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Отомикоз: грибковое поражение кожи ушной раковины, наружного слухового прохода, барабанной перепонки, барабанной полости или послеоперационной полости среднего уха. Основными возбудителями являются плесневые грибы Aspergillus и дрожжеподобные грибы Candida. Течение хроническое, рецидивирующее.
- Диагноз устанавливается только после выявления возбудителя: микроскопия и посев отделяемого из уха на грибы. Однократный отрицательный результат микоз не исключает.
- Лечение: тщательный туалет уха врачом и местные противогрибковые аппликации, при среднем отите и микозе послеоперационной полости — также противогрибковые препараты внутрь. Критерий излечения: клиническое выздоровление в течение месяца и отрицательное микологическое исследование.
- Госпитализация:
  1. осложнённый грибковый средний отит;
  2. лабиринтит;
  3. невозможность ежедневного туалета уха;
  4. нет эффекта амбулаторного лечения наружного грибкового отита **за 5–7 дней**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение и формы

1. грибковый наружный отит: плесневые или дрожжеподобные грибы на коже ушной раковины, стенках наружного слухового прохода, барабанной перепонке;
2. грибковый мирингит: плесневые грибы на барабанной перепонке;
3. грибковый средний отит: плесневые и дрожжеподобные грибы в барабанной полости;
4. микоз послеоперационной полости среднего уха.

Синоним: отомикоз (ОМ).

Классификация

1. по локализации: наружный грибковый отит, грибковый мирингит, грибковый средний отит, грибковый средний послеоперационный отит;
2. по возбудителю: плесневой, дрожжеподобный, смешанный;
3. по течению: хронический.

2.2 Возбудители и предрасполагающие факторы

Основными возбудителями являются плесневые грибы рода Aspergillus и дрожжеподобные грибы рода Candida. Все возбудители условно-патогенные: заболевание развивается при наличии предрасполагающих факторов.

Частота возбудителей

1. аспергиллёз: 65% случаев;
2. кандидоз: 30%;
3. Penicillium, Mucor, Alternaria, Geotrichum, Cladosporium и другие грибы: до 5%;
4. сочетанное поражение Aspergillus и Candida: 15% случаев.

Виды: Aspergillus niger, fumigatus, oryzae, flavus и другие; Candida albicans, tropicalis, krusei, glabrata, parapsilosis и другие; Penicillium notatum и другие.

Предрасполагающие факторы

1. травма кожи при чрезмерной гигиене слухового прохода с удалением защитной серы;
2. сахарный диабет: глюкоза в ушной сере повышается уже на ранних стадиях;
3. соматические заболевания, нарушение обмена веществ, гиповитаминоз;
4. длительная системная и местная антибиотикотерапия, кортикостероиды;
5. иммунодепрессанты, лучевая терапия.

Микоз послеоперационной полости

1. длительное воспаление в полости с повреждением эпителия;
2. травма уха, в том числе операционная;
3. попадание нестерильной воды;
4. влажность, запылённость, производственный контакт с антибиотиками.

Для грибкового отита характерно рецидивирующее течение.

2.3 Жалобы и анамнез

Наружный грибковый отит

1. жидкие выделения (кандидоз);
2. корочки и пробки в слуховом проходе (аспергиллёз);
3. зуд, боль, заложенность уха;
4. в острой стадии иногда головная боль, лихорадка, болезненность раковины, заушной области и слухового прохода.

Слух не снижен или снижен незначительно по кондуктивному типу.

Грибковый средний отит

1. снижение слуха;
2. выделения из уха;
3. периодический зуд;
4. возможны головокружения.

Течение длительное; обострения — выраженная боль, зуд, заложенность, выделения, головная боль, головокружение.

В анамнезе уточняют

1. начало и течение болезни, частоту и характер обострений;
2. прежние отиты и микозы другой локализации;
3. прежнее лечение и его эффект;
4. лечение антибиотиками, кортикостероидами, иммунодепрессантами: длительность и интенсивность;
5. производственные и бытовые условия, аллергологический анамнез.

Для отомикоза характерны учащение обострений и слабый эффект стандартного лечения.

2.4 Картина по возбудителю

Возбудитель	Картина
Дрожжеподобные (Candida)	1. в процесс может вовлекаться кожа раковины и околоушной области; 2. гиперемия, инфильтрация и мацерация кожи слухового прохода, гиперемия барабанной перепонки; 3. при среднем отите утолщение слизистой, густое мутное отделяемое; нарушение эпителизации послеоперационной полости; 4. беловатое, менее густое отделяемое; на раковине эрозии, легко снимающиеся беловатые налёты; возможен хондроперихондрит.

Возбудитель	Картина
Aspergillus	1. казеозно-некротические массы; 2. инфильтрация сильнее в костном отделе, возможен мирингит; 3. беловато-серые наложения с чёрными вкраплениями: «молотый перец», «промокшая газета»; 4. Aspergillus glaucus: зеленоватое отделяемое.
Penicillium	1. желтоватое отделяемое, иногда как сера, по всему слуховому проходу; 2. инфильтрация кожи, сухие корочки и плёнки.
Geotrichum capitatum	1. выраженная инфильтрация кожи, мирингит; 2. плотные «замазкообразные» серовато-жёлтые массы по всему слуховому проходу.

3. Диагностика

Диагноз основан на комплексе: жалобы, анамнез, физикальное, лабораторное и инструментальное обследование.

3.1 Отомикроскопия

Показания

1. все пациенты: осмотр наружного слухового прохода, барабанной перепонки, барабанной полости и послеоперационной полости под микроскопом, отоскопом или торцевым эндоскопом.

Общий признак всех форм

1. окрашенное отделяемое в слуховом проходе и (или) среднем ухе.

Диагноз «отомикоз» устанавливается только после выявления возбудителя.

Форма	Отоскопические признаки
Кандидоз наружного слухового прохода	1. умеренное сужение просвета, сильнее в хрящевом отделе; 2. барабанная перепонка гиперемирована; 3. отделяемое жидкое, беловатое, творожистое; 4. процесс часто переходит на кожу раковины.
Аспергиллёз	1. сужение за счёт инфильтрации, сильнее в костном отделе; 2. барабанная перепонка почти всегда инфильтрирована, утолщена, без опознавательных контуров; иногда грануляции; 3. обильное отделяемое разных оттенков серого, иногда с чёрными точками, холестеатомо- или сероподобное, как промокшая газета.
Пенициллиоз	1. процесс в хрящевом отделе, умеренная инфильтрация без полного закрытия прохода; 2. барабанная перепонка гиперемирована, иногда эрозирована или выпячена — ложное впечатление перфорации; 3. отделяемое оттенков жёлтого, как сера, по всему проходу, с сухими корочками и плёнками.

Форма	Отоскопические признаки
Грибковый средний отит	1. специфическое отделяемое, цвет и консистенция по виду гриба; 2. часто сопутствует наружный отит; 3. барабанная перепонка гиперемирована, инфильтрирована, перфорации разного размера; 4. слизистая барабанной полости гиперемирована, инфильтрирована, иногда грануляции.
Микоз послеоперационной полости	1. эпителизации нет или она резко замедлена; 2. стенки прохода гиперемированы, неравномерно инфильтрированы; 3. неотимпанальная полость заполнена отделяемым, как при отомикозе другой локализации; 4. мелкие кровоточащие грануляции.

3.2 Микологическое исследование отделяемого из уха

Показания

1. все пациенты: микроскопия отделяемого на дрожжевые и мицелиальные грибы, посев на дрожжевые и на мицелиальные грибы.

При хроническом отите обязательно, если

1. частые обострения (**1 раз в 2 месяца**);
2. противовоспалительная антибактериальная терапия неэффективна;
3. характерная отоскопическая картина микоза.

После лечения проводятся контрольные исследования.

Забор и исследование материала

1. материал берут аттиковым зондом или ложкой Фолькмана из глубоких отделов слухового прохода под контролем микроскопа, отоскопа или эндоскопа;
2. помещают между двумя обезжиренными стерильными стёклами, микроскопия при увеличении ×100, ×200, ×400;
3. микроскопия является наиболее информативным методом и надёжно определяет возбудителя;
4. критерий микоза при посеве: титр грибов **не менее 10^4 КОЕ/мл**.

Повторное исследование: однократный отрицательный результат не исключает грибковое заболевание, а единичный рост грибов в посеве не всегда означает микоз. Решающее значение имеют микологические методы, а не отоскопия.

3.3 Анализы крови

Показания

1. затяжное и рецидивирующее течение: поиск сопутствующих и фоновых заболеваний.

Исследования

1. общий (клинический) анализ крови;
2. биохимия: глюкоза, общий белок, АСТ, АЛТ, креатинин;
3. антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2;
4. антитела к бледной трепонеме;
5. HBsAg (гепатит B), антиген вируса гепатита C.

При поражении уха на фоне системных, в том числе инфекционных, заболеваний показаны консультация соответствующего специалиста и дообследование.

4. Лечение

Всем пациентам лечение начинают с элиминации возбудителя: противогрибковая терапия и тщательный туалет слухового прохода, барабанной или послеоперационной полости. Учитывают прежние эпизоды микоза и местные противогрибковые препараты.

Местную терапию начинают, не дожидаясь результатов посева.

Схема лечения отомикоза

Локализация	Дрожжеподобные грибы	Плесневые грибы
Наружное ухо, местно	нафтифин 1% раствор + клотримазол 1% раствор	нафтифин 1% раствор + хлорнитрофенол 1% раствор
Среднее ухо, местно	нафтифин 1% раствор + клотримазол 1% раствор	нафтифин 1% раствор + хлорнитрофенол 1% раствор
Среднее ухо, внутрь	#флуконазол, капсулы	#итраконазол, капсулы
Послеоперационная полость, местно	нафтифин 1% раствор + клотримазол 1% раствор	нафтифин 1% раствор + хлорнитрофенол 1% раствор
Послеоперационная полость, внутрь	флуконазол, капсулы	итраконазол, капсулы, или #тербинафин, таблетки (с 3 лет)

4.1 Наружный грибковый отит

Кандидозный отит: аппликации 1% раствора #клотримазола и 1% раствора #нафтифина.

1. по 5–10 минут 2 раза в сутки, **14 дней**;
2. затем ещё **14 дней** после стихания клинических признаков и (или) до 3-кратного отрицательного анализа.

Возможны также миконазол, натамицин, #эконазол.

Плесневые грибы: аппликации #хлорнитрофенола и 1% раствора #нафтифина на кожу слухового прохода.

1. по 5–10 минут 2 раза в день, **10–14 дней**;
2. затем ещё **14 дней** после стихания клинических признаков и (или) до 3-кратного отрицательного анализа.

Грибково-бактериальная ассоциация: применяют комбинированные ушные капли #хлорамфеникол + беклометазон + клотримазол + лидокаин.

1. по 4–5 капель 3–4 раза в день, **10 дней**; детям **с 6 лет**.

4.2 Грибковый средний отит и микоз послеоперационной полости

Candida: помимо местного лечения назначают противогрибковый препарат внутрь — #флуконазол в возрастной дозе.

Плесневые грибы: назначают итраконазол или тербинафин внутрь; местная терапия — как при наружном грибковом отите.

Дозы противогрибковых препаратов системного действия

1. #флуконазол: внутрь 50–100 мг 1 раз в сутки, **14 дней**;
2. #итраконазол: внутрь 200 мг 1 раз в сутки, **10–14 дней**;
3. #тербинафин: внутрь 250 мг в сутки, **16 дней**.

Возрастная группа в таблице 2 КР не указана. Детям #флуконазол назначается в возрастной дозировке, конкретная доза в КР не приведена; #тербинафин — **с 3 лет** (таблица 1 КР).

Критерий эффективности: полное клиническое излечение **в течение месяца**, подтверждённое клинической картиной и отрицательным микологическим исследованием.

Общая длительность противогрибковой терапии местного и (или) системного действия, по критериям качества КР, — **28 дней и более**.

Свойства препаратов для местного лечения

1. нафтифин: фунгистатичен к Candida, фунгициден к плесневым грибам, есть противовоспалительный эффект, долго держит концентрацию в коже;
2. хлорнитрофенол: противогрибковое и антибактериальное действие, в высоких концентрациях активен и против Proteus и синегнойной палочки;
3. клотримазол: высокоспецифичен к Candida, преимущественно фунгистатичен.

4.3 Туалет уха

Перед местной терапией ухо тщательно очищают от отделяемого у всех пациентов.

Туалет уха выполняет только врач: аттиковым зондом и (или) ушным зондом с ватой, смоченной противогрибковым препаратом, или вакуум-экстрактором. Даже небольшое количество грибковых масс заметно удлиняет лечение.

Особенности

1. наружный отит: особенно передненижний отдел слухового прохода;
2. средний отит: полностью удалить массы из области перфораций; при больших перфорациях промывание барабанной полости 0,01% раствором бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония;
3. послеоперационный микоз: очищают всю неотимпанальную полость, особенно задний отдел за шпорой.

Препарат вводят в ухо на турунде: спиртсодержащие капли раздражают слуховой проход, а при среднем отите вызывают резкую боль, отёк слизистой, усугубление мукозита и грануляции. Турунда удлиняет действие препарата.

4.4 Хирургическое лечение

Показания

1. полипы, грануляции: до медикаментозной терапии удаление или туширование 10% раствором нитрата серебра.

После туширования обязательна обработка местным противогрибковым препаратом, например нафтифином или хлорнитрофенолом.

4.5 Немедикаментозное лечение

Физиотерапия не рекомендуется. Следует ограничить воздействие пыли, газов и повышенной влажности; решающее значение имеет предотвращение попадания воды в ухо.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. осложнённые формы грибкового среднего отита;
2. лабиринтит;
3. невозможность ежедневного адекватного туалета слухового прохода;
4. неэффективность адекватной амбулаторной терапии наружного грибкового отита **в течение 5–7 дней**.

Первичную помощь оказывают врачи общей практики и оториноларингологи первичного звена. Медицинская реабилитация не проводится.

5.2 Диспансерное наблюдение и профилактика

Частота осмотров

1. все пациенты с грибковым отитом: осмотр оториноларинголога **1 раз в 3 месяца**, при благоприятном течении **1 раз в полгода**, в течение **2 лет**.

Профилактика

1. правильный туалет слухового прохода и ушной раковины;
2. коррекция гликемии;
3. общеукрепляющая терапия.

Профилактика рецидивов

1. динамическое наблюдение в течение **6 месяцев**;
2. курс профилактического лечения;
3. смазывание кожи слухового прохода нафтифином или хлорнитрофенолом 1 раз в неделю в течение **4–6 недель**.

Повторные посевы из уха выполняют до микробиологического подтверждения элиминации возбудителя.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Грибковый отит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	`304_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Грипп у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J09** — Грипп, вызванный определенным идентифицированным вирусом гриппа **J10** — Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа **J11** — Грипп, вирус не идентифицирован
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/749_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Грипп — острая инфекционная болезнь с аэрогенным механизмом передачи, вызываемая вирусами гриппа A, B или C; характеризуется массовым распространением, кратковременной лихорадкой, интоксикацией и поражением респираторного тракта.
- Возбудитель подтверждается экспресс-тестом (иммунохроматография мазка из носоглотки) при обращении **не позднее 2 суток** от появления симптомов или ПЦР мазка из носоглотки; в стационаре ПЦР выполняется всем **в первые сутки** госпитализации. В период эпидемического подъёма диагноз может быть установлен и по клинико-эпидемиологическим данным.
- Противовирусные препараты прямого действия начинают **не позднее 48 часов** (занамивир — **в первые 36 часов**) от манифестации, не дожидаясь лабораторного подтверждения; наилучший эффект — при начале **в первые 12 часов**.
- **Оториноларингологу**
  1. осложнения со стороны ЛОР-органов: синуситы, отиты, тубоотиты, лакунарная и фолликулярная ангина;
  2. при подозрении на бактериальный синусит выполняется рентгенография околоносовых пазух;
  3. при выраженном затруднении носового дыхания — местные адреномиметики **не более 5 дней**.
- **Показания к госпитализации**
  1. тяжёлое и среднетяжёлое течение;
  2. проживание в общежитии, неблагоприятные условия жилой среды;
  3. принадлежность к группе риска неблагоприятного течения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Грипп (Grippus, Influenza) — острая инфекционная болезнь с аэрогенным механизмом передачи возбудителя, вызываемая вирусами гриппа A, B или C, характеризующаяся массовым распространением, кратковременной лихорадкой, интоксикацией и поражением респираторного тракта.

2.2 Этиология и эпидемиология

Возбудителями являются РНК-содержащие вирусы семейства ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), роды A, B, C и D. Основные поверхностные белки — гемагглютинин (H), основной иммуноген, и нейраминидаза (N); мутации нейраминидазы приводят к резистентности к её ингибиторам. Выделяют 18 подтипов гемагглютинина и 11 вариантов нейраминидазы вируса A.

Эпидемиология

1. источник — больной в остром периоде (первые 5–7 дней), в том числе с лёгкой и бессимптомной формой, реже реконвалесцент, выделяющий вирус в среднем 2 недели;
2. механизм передачи аэрогенный (воздушно-капельный и воздушно-пылевой пути), радиус рассеивания 2–3 м; контактно-бытовой имеет значительно меньшее значение;
3. восприимчивость всеобщая; эпидемии в крупных городах длятся в среднем 6–8 недель, пандемии вызываются новыми шифтовыми вариантами вируса.

2.3 Классификация

1. **по течению** — типичное (манифестное), атипичное (бессимптомное, стёртое)
2. **по тяжести** — лёгкая, средняя, тяжёлая, очень тяжёлая (гипертоксическая) степень
3. **по характеру течения** — неосложнённое и осложнённое: специфические (вирус-ассоциированные) осложнения, бактериальные осложнения, обострение или декомпенсация хронических заболеваний

2.4 Клиническая картина

Инкубационный период — **от 1 до 4 дней**, в среднем около 48 часов. Типичный грипп у взрослых начинается внезапно.

Типичные симптомы

1. озноб, лихорадка, прострация;
2. боли в мышцах и суставах, преимущественно нижних конечностей;
3. сильная головная боль, часто со светобоязнью и болезненностью при надавливании на глазные яблоки или при движении ими;
4. вначале лёгкие респираторные симптомы: першение в горле, жжение за грудиной, непродуктивный кашель, иногда насморк;
5. позже — преобладание поражения нижних дыхательных путей, кашель стойкий и продуктивный.

Острые симптомы проходят **через 2–3 дня**, лихорадка может длиться **до 5 дней**; кашель и слабость сохраняются дни и недели.

При неосложнённом гриппе характерны лейкопения с нейтропенией, относительный лимфоцитоз и моноцитоз; СОЭ у большинства нормальная. На рентгенограмме лёгких в остром периоде — усиление сосудистого рисунка.

Критерии оценки тяжести течения гриппа

Признак	Лёгкая	Средняя	Тяжёлая	Очень тяжёлая
Лихорадка	до 38,5 °C	38,6–39,5 °C	более 39,6 °C	свыше 40,0 °C
Пульс и систолическое АД	пульс менее 90 в минуту, САД 110 мм рт. ст. и выше	пульс 90–120, САД менее 110	пульс более 120, нередко аритмичен, САД менее 90, тоны сердца глухие	пульс более 120, нередко аритмичен, САД менее 90, тоны сердца глухие
Частота дыхательных движений	16–23	более 24	более 28	более 28
Менингеальный синдром, сознание, судороги	отсутствуют	отсутствуют	менингеальный синдром возможен, оглушение, сопор, возможны судороги и бред	менингеальный синдром часто, сопор, кома, возможны судороги, часто бред и делирий
Длительность заболевания	до 6 дней	6–8 дней	9 дней и более	молниеносное течение

Осложнения гриппа

1. вирусная пневмония, ОРДС, токсический геморрагический отёк лёгких, ложный круп, острая дыхательная недостаточность;
2. инфекционно-токсический шок, инфекционно-токсическая энцефалопатия, отёк головного мозга;
3. неврологические осложнения: менингит, энцефалит, синдром Гийена — Барре, невриты; синдром Рея; миокардит;
4. вторичная бактериальная или вирусно-бактериальная пневмония, септический шок;
5. осложнения со стороны ЛОР-органов: гаймориты, отиты, фронтиты, синуситы, тубоотиты, лакунарная и фолликулярная ангина;
6. декомпенсация хронических заболеваний: бронхиальной астмы, ХОБЛ, хронической сердечной недостаточности, заболеваний печени и почек.

Осложнения возникают у 10–15% больных. Постгриппозные пневмонии развиваются **в конце 1-й — начале 2-й недели** болезни. Частые осложнения гриппа — синуситы и отиты. Тяжёлым осложнением является отёк головного мозга: сильная головная боль, рвота, судороги, нарушение сознания, менингеальный синдром.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. эпидемиологического и клинического анамнеза;
2. клинического осмотра;
3. лабораторных и специальных методов обследования.

При этом определяются клиническая форма и тяжесть болезни, осложнения и показания к терапии. В период эпидемических подъёмов диагноз «грипп» может быть установлен как по лабораторному подтверждению, так и по клиническим и эпидемиологическим данным.

3.2 Жалобы и анамнез

Что уточнить

1. сроки появления лихорадки и интоксикации, ломоту в мышцах и суставах, боль при движении глазных яблок, катаральные явления, боль в грудной клетке;
2. контакт с больным гриппоподобным заболеванием или с подтверждённым гриппом **менее чем за 7 дней** до первых симптомов, эпидемический подъём заболеваемости;
3. приём противовирусных препаратов до обращения;
4. сопутствующие хронические заболевания и беременность.

3.3 Физикальное обследование

При общем осмотре

1. цвет и влажность кожи и видимых слизистых оболочек, инъекция сосудов склер;
2. одышка, мокрота, дистанционные хрипы;
3. положение и поведение пациента;
4. жизненно важные показатели: ЧДД, АД, ЧСС, температура тела.

3.4 Лабораторные исследования

Общий анализ крови и общий анализ мочи выполняются всем пациентам с подозрением на грипп.

1. **неосложнённый грипп** — нормоцитоз или лейкопения, нейтропения, эозинопения, относительный лимфо- и моноцитоз
2. **бактериальные осложнения (пневмония, синусит)** — нарастают лейкоцитоз, палочкоядерный нейтрофилёз, СОЭ
3. **интерстициальное вирусное поражение лёгких** — лейкопения, нейтрофилёз с палочкоядерным сдвигом, анемия, тромбоцитопения

Специфическая диагностика

1. амбулаторно — иммунохроматографический экспресс-тест мазка из носоглотки на антигены вирусов А и В всем, кто обратился **не позднее 2 суток** от появления симптомов;
2. амбулаторно — ПЦР мазка из носоглотки по клинико-эпидемиологическим показаниям: эпидемический очаг, лихорадка **выше 38**, подозрение на поражение нижних дыхательных путей, возраст **старше 65 лет**, хроническая соматическая патология;
3. в стационаре — ПЦР мазка из носоглотки всем пациентам с симптомами ОРВИ **в первые сутки** госпитализации.

Для дифференциальной диагностики выявляют другие возбудители ОРВИ и SARS-CoV-2: экспресс-тестом и ПЦР мазков из носо- и ротоглотки; в стационаре — всем в первый день госпитализации. При подозрении на поражение нижних дыхательных путей исследуют мокроту, аспират из трахеи, жидкость бронхоальвеолярного лаважа.

Серологическое исследование парных сывороток (первая — в день диагноза, вторая — через 2–3 недели) применяется в стационаре для ретроспективной диагностики при невозможности ПЦР; достоверно нарастание титра **в 4 раза и более**.

При тяжёлом и осложнённом течении

1. биохимический анализ крови: билирубин, альбумин, мочевина, креатинин, глюкоза, АСТ, АЛТ, тропонины;
2. кислотно-основное состояние и газы крови — при дыхательной недостаточности;
3. коагулограмма — при геморрагическом синдроме;
4. электролиты крови;
5. маркеры воспаления: фибриноген, прокальцитонин, С-реактивный белок (СРБ).

3.5 Инструментальные исследования

Пульсоксиметрия выполняется всем пациентам на всех этапах помощи; при SpO_2 **менее 90%** исследуют газы артериальной крови и лактат.

Рентгенография или КТ органов грудной клетки показана при явлениях бронхита с физикальными признаками поражения лёгочной ткани; ЭКГ — при осложнённом течении и аускультативных изменениях в сердце.

Рентгенография околоносовых пазух выполняется при катаральных проявлениях в остром периоде или их появлении на фоне терапии, при подозрении на синусит, вызванный присоединением бактериальной флоры.

Спинномозговая пункция с исследованием ликвора проводится при менингеальных симптомах для разграничения менингизма и менингита; при менингизме изменений ликвора нет.

3.6 Консультации специалистов

1. **невролог** — при явлениях менингоэнцефалита
2. **пульмонолог** — при признаках пневмонии
3. **гематолог** — при выраженных гематологических изменениях и геморрагическом синдроме
4. **кардиолог** — при миокардите, острой сердечно-сосудистой недостаточности
5. **акушер-гинеколог** — при гриппе на фоне беременности

Осмотр анестезиолога-реаниматолога для перевода в ОРИТ показан при быстропрогрессирующей острой дыхательной недостаточности: ЧДД **более 25** в минуту, SpO_2 **менее 92%**, а также при другой органной недостаточности (**2 и более балла** по шкале SOFA).

Дифференциальная диагностика проводится с двумя группами инфекций: протекающими с катарально-респираторным синдромом и с ранним развитием лихорадочно-интоксикационного синдрома.

---

4. Лечение

4.1 Противовирусная терапия

Противовирусные препараты прямого действия как препараты первой линии начинают **не позднее 48 часов** (занамивир — **в первые 36 часов**) после манифестации всем пациентам с симптомами гриппа.

1. лечение начинают немедленно, не дожидаясь лабораторного подтверждения;
2. вакцинация и тяжесть болезни на решение не влияют;
3. наилучший эффект достигается при начале **в первые 12 часов**;
4. при отсутствии лечения в ранние сроки препарат может быть начат на любом этапе разгара болезни при предполагаемой репликации вируса.

Амантадин и римантадин для лечения гриппа не рекомендуются: большинство штаммов вируса А к ним резистентны.

4.2 Лёгкое и среднетяжёлое неосложнённое течение (амбулаторно)

Ингибиторы нейраминидазы — осельтамивир и занамивир. Пациентам вне группы риска с неосложнённым гриппом их назначать не следует.

1. осельтамивир: внутрь по 75 мг 2 раза в сутки, 5 дней; с осторожностью при беременности и грудном вскармливании;
2. занамивир: по 2 ингаляции (по 5 мг) 2 раза в сутки, 5 дней; при резистентности к осельтамивиру, беременным, при тяжёлой почечной недостаточности; не распылять аэрозольным ингалятором.

Балоксавир марбоксил назначается взрослым и детям **старше 12 лет**, в том числе с риском осложнений; прекращает выделение вируса **в течение 1 суток** и активен в отношении штаммов, резистентных к ингибиторам нейраминидазы.

1. масса тела **40–80 кг**: 40 мг внутрь однократно;
2. масса тела **80 кг и более**: 80 мг однократно.

Другие противовирусные препараты прямого действия

1. умифеновир: внутрь до еды по 200 мг 4 раза в сутки, 5 дней; противопоказан в I триместре беременности;
2. риамиловир: внутрь по 250 мг 3 раза в сутки, 5 дней, начать **не позднее 2-го дня** болезни; противопоказан при беременности и грудном вскармливании;
3. энисамия йодид: внутрь по 500 мг 3 раза в сутки, 5–7 дней.

Иммунотропные препараты с опосредованным противовирусным действием (интерфероны, иммуностимуляторы) применяются как препараты второй линии.

1. имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты;
2. XC221GI;
3. интерферон альфа-2b, интерферон гамма человеческий рекомбинантный интраназально;
4. тилорон;
5. меглюмина акридонацетат;
6. азоксимера бромид;
7. Эргоферон, Рафамин;
8. инозин пранобекс.

При отсутствии эффекта **в течение 24 часов** переходят на противовирусные препараты прямого действия.

1. имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты: 90 мг 1 раз в сутки, 5–7 дней, начать желательно **не позднее 2 суток**; при выраженных симптомах и сопутствующих заболеваниях — 180 мг/сут первые 3 дня;
2. XC221GI: по 100 мг 2 раза в день, 5 дней;
3. интерферон альфа-2b: интраназально по 3 капли в каждый носовой ход 5–6 раз в день, 5 дней; интерферон гамма: по 2 капли 5 раз в день;
4. тилорон: 125 мг 1 раз в сутки первые 2 дня, затем 125 мг через день (курсовая доза 750 мг);
5. меглюмина акридонацетат: 450–600 мг 1 раз в сутки на 1, 2, 4, 6, 8-е сутки;
6. азоксимера бромид: по 1 таблетке сублингвально 2 раза в день, 7 дней;
7. инозин пранобекс: 6–8 таблеток в сутки в 3–4 приёма.

Всем пациентам показана пероральная дезинтоксикационная терапия: 2–3 литра жидкости в сутки.

При гипертермии **выше 38 °C**, мышечных и суставных болях применяют НПВП или анилиды.

1. ибупрофен: внутрь по 200–400 мг 3–4 раза в сутки, 3–10 дней, не более 1200 мг/сут;
2. парацетамол: по 500–1000 мг до 4 раз в сутки, не более 4000 мг/сут;
3. при выраженных лихорадочно-интоксикационном и респираторном синдромах — комбинации ибупрофен + парацетамол, парацетамол + фенилэфрин + фенирамин.

1. **бронхит с бронхообструкцией и влажным кашлем** — отхаркивающие препараты: ацетилцистеин, бромгексин, амброксол
2. **сухой непродуктивный надсадный кашель** — противокашлевые препараты: бутамират, комбинации с декстрометорфаном

Одновременное применение отхаркивающих и противокашлевых препаратов не рекомендуется: подавление кашлевого рефлекса способствует застою мокроты.

При выраженном затруднении носового дыхания в комплексной терапии ринита и риносинусита применяют местные адреномиметики **не более 5 дней**: они облегчают заложенность носа и восстанавливают проходимость слуховой трубы.

1. ксилометазолин: 0,1% раствор по 2–3 капли или 1 впрыскивание в каждый носовой ход 4 раза в день; противопоказан при беременности;
2. оксиметазолин: 0,025–0,05% раствор по 1–2 капли 2–3 раза в сутки; при беременности и грудном вскармливании — с осторожностью.

4.3 Осложнённое, тяжёлое и крайне тяжёлое течение (стационар)

При поступлении

1. оценить характер поражения органов дыхания и компенсацию сопутствующих болезней;
2. измерить основные физиологические константы;
3. выполнить рентгенографию лёгких и ЭКГ;
4. взять материал для специфической диагностики.

Сразу после поступления начинают осельтамивир, занамивир или балоксавир марбоксил в обычных дозах.

При тяжёлом или прогрессирующем заболевании и тяжёлой иммуносупрессии без ответа на стандартный режим целесообразен #осельтамивир по 150 мг 2 раза в сутки **не менее 10 дней**; с осторожностью при почечной недостаточности.

Меглюмина натрия сукцинат внутривенно капельно применяют при среднетяжёлом и тяжёлом течении и пневмонии для купирования интоксикации: в среднем 10 мл/кг в сутки, курс **до 11 дней**.

При гипоксемии проводится оксигенотерапия: при SpO_2 **менее 92%** — ингаляция кислорода через носовые катетеры или лицевую маску; при острой дыхательной недостаточности — интубация трахеи и ИВЛ, в крайне тяжёлых случаях ОРДС — ЭКМО.

Стрессовые (малые и средние) дозы системных глюкокортикостероидов применяют при рефрактерном септическом шоке и ранней фазе ОРДС — по рекомендациям по неотложным состояниям в ОРИТ.

Антибактериальная терапия проводится при сопутствующей бактериальной инфекции, неэффективности противовирусной и симптоматической терапии, ОРДС и подозрении на вирусно-бактериальную пневмонию — по рекомендациям по внебольничной пневмонии и ОРДС.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Вакцинация проводится всем, не имеющим противопоказаний, в предэпидемический период и заканчивается **за 2–3 недели** до начала эпидемического сезона.

В первую очередь прививают

1. беременных;
2. взрослых **старше 60 лет**;
3. лиц с хроническими заболеваниями, в том числе лёгких и сердечно-сосудистыми, с ожирением;
4. работников медицинских и образовательных организаций.

Экстренную химиопрофилактику ингибиторами нейраминидазы проводят избирательно; если с первого контакта прошло **более 48 часов**, она не рекомендуется. Плановая профилактика осельтамивиром не рекомендуется из-за резистентности. Химиопрофилактика не заменяет вакцинацию.

1. #осельтамивир: по 75 мг 1 раз в сутки **не менее 10 дней** после контакта, начать **в первые 2 дня**;
2. занамивир: 2 ингаляции по 5 мг 1 раз в день, 10 дней;
3. балоксавир марбоксил: однократно **в течение 48 часов** после контакта, 40 мг при массе 40–80 кг, 80 мг при 80 кг и более;
4. умифеновир: по 200 мг в день 10–14 дней после контакта.

При больном в семье

1. изолировать больного в отдельном помещении или за ширмой на расстоянии более 1 м;
2. часто проветривать и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами;
3. кипятить посуду больного, мыть руки после каждого контакта;
4. носить маски со сменой каждые 2 часа.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. тяжёлое и среднетяжёлое течение гриппа;
2. проживание в общежитиях и в условиях неблагоприятных факторов жилой среды;
3. принадлежность к группе риска неблагоприятного течения болезни.

Признаки прогрессирования — схему ведения пересматривают срочно

1. одышка, затруднённое дыхание, синюшность, кровянистая мокрота, боль в груди, гипотония, гипоксия по пульсоксиметру;
2. изменение психического состояния, сонливость, судороги, спутанность сознания, сильная слабость или паралич;
3. устойчивая репликация вируса или вторичная бактериальная инфекция, в том числе высокая температура **более 3 дней**;
4. тяжёлое обезвоживание.

Показания к переводу в ОРИТ (достаточно одного)

1. быстро прогрессирующая острая дыхательная недостаточность, нарастающая одышка, цианоз;
2. ЧДД **более 30** в минуту, SpO_2 **менее 90%**, систолическое АД **менее 90 мм рт. ст.**;
3. шок, дисфункция ЦНС (менее 15 баллов по шкале комы Глазго);
4. острая почечная или печёночная дисфункция, коагулопатия.

Критерии выписки

1. нормализация температуры тела;
2. купирование респираторно-катарального синдрома;
3. нормальные показатели общего анализа крови.

Группы риска тяжёлого течения

1. беременные на любом сроке и в послеродовом периоде;
2. хронические заболевания лёгких, сердечно-сосудистой системы, почек, печени;
3. сахарный диабет, ожирение 2–3 степени;
4. неврологические состояния, гемоглобинопатии;
5. первичные и вторичные иммунодефициты, злокачественные новообразования;
6. возраст **65 лет и старше**.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Грипп у взрослых»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 26.09.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	749_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского; Российское научное медицинское общество

	терапевтов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Раздел 3.1.1 рекомендует противовирусные препараты прямого действия «всем пациентам с симптомами гриппа», а комментарий к осельтамивиру и занамивиру указывает, что пациентам вне группы риска с неосложнённым гриппом ингибиторы нейраминидазы назначать не следует.
- Пороги дыхательной недостаточности различаются: для осмотра анестезиолога-реаниматолога (раздел 2.5) — ЧДД более 25 в минуту и SpO_2 менее 92%, для перевода в ОРИТ (приложение А3) — ЧДД более 30 и SpO_2 менее 90%.

Клинические рекомендации

Грипп у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J09** — Грипп, вызванный определенным идентифицированным вирусом гриппа **J10** — Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа **J11** — Грипп, вирус не идентифицирован
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.07.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/249_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Гриппом называют острое респираторное вирусное заболевание, при котором лихорадка и симптомы общей интоксикации доминируют над умеренным катаральным синдромом верхних отделов респираторного тракта.
- Диагноз подтверждается лабораторно: экспресс-тестом (ИХГ) носоглоточного мазка или ПЦР мазка из ротоглотки. В период эпидемического подъёма диагноз может быть установлен и по клинико-эпидемиологическим данным.
- Противовирусную терапию начинают **в первые 48 часов** от манифестации по клиническому подозрению, не дожидаясь лабораторного подтверждения. Ингибиторы нейраминидазы (осельтамивир, занамивир) показаны при тяжёлом и осложнённом течении и детям из групп риска.
- Антибактериальные препараты системного действия назначаются только при вторичных бактериальных осложнениях: синусите, тонзиллите, отите, пневмонии.
- **Признаки утяжеления**
  1. цианоз и одышка при нагрузке или в покое;
  2. кашель с примесью крови, боль или тяжесть в груди;
  3. спутанность сознания, возбуждение, судороги;
  4. повторная рвота, снижение АД и мочеотделения;
  5. высокая температура и интоксикация **более 3 дней**;
  6. у детей раннего возраста — учащённое или затруднённое дыхание, вялость, трудности с пробуждением, затруднение сосания.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Грипп (от фр. grippe — охватить; лат. influenza — вторгаться) — острое респираторное вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой и симптомами общей интоксикации, доминирующими над умеренным катаральным синдромом в верхних отделах респираторного тракта.

2.2 Этиология и эпидемиология

Возбудители — РНК-содержащие вирусы семейства Orthomyxoviridae, типы A, B, C и D. Подтипы вируса A определяются сочетанием гемагглютинина (H) и нейраминидазы (N); эпидемическое значение для людей имеют H1, H2, H3 и N1, N2. Вирус B делится на линии Ямагата и Виктория.

Эпидемиология

1. путь передачи воздушно-капельный, возможен контактный через контаминированные поверхности;
2. восприимчивость всеобщая;
3. источник — больные в остром периоде, в том числе с лёгкой и бессимптомной формой; реконвалесценты выделяют вирус в среднем 2 недели (при гриппе A — до 22–25, при гриппе B — до 30 дней);
4. сезонность — зима и весна; эпидемии обусловлены антигенным дрейфом, пандемии — шифтом вируса A.

В 2022 г. заболеваемость гриппом детей в России составила 165,8 на 100 тыс.; наибольшая — в возрасте 1–2 лет (312,5) и до 1 года (291,4).

2.3 Классификация

1. **по типу вируса** — грипп A (A/H1N1, A/H3N2 и др.), грипп B (линии Ямагата и Виктория), грипп C
2. **по тяжести** — лёгкая, среднетяжёлая, тяжёлая (токсическая), гипертоксическая
3. **по течению** — гладкое (неосложнённое) и негладкое (с осложнениями, вторичной инфекцией, обострением хронических заболеваний)
4. **по наличию симптомов** — типичный, атипичный (стёртый, бессимптомный)
5. **по локализации поражения** — острый ринит, фарингит, трахеит, ларингит, бронхит и их сочетания (например, ринофарингит)

2.4 Клиническая картина

Грипп, как правило, начинается на фоне полного здоровья или после короткого (1–2 часа) продромального периода. Интоксикация преобладает над поражением респираторного тракта: температура уже в первые часы достигает максимума (**38,5–40 °C**).

1. **интоксикационный синдром** — озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль при движении глазными яблоками, светобоязнь, слезотечение, резкая слабость; возможны головокружение, обмороки, бред, галлюцинации, судороги
2. **катаральный синдром** — выражен нерезко: затруднение носового дыхания, скудный слизисто-серозный ринит, сухость слизистых оболочек, першение в горле, сухой кашель, у старших детей — «трахеитный» с болью за грудиной; умеренная гиперемия дужек с синюшным оттенком, зернистость и инъекция сосудов мягкого нёба и задней стенки глотки
3. **геморрагический синдром** — носовые кровотечения, петехиальная сыпь на лице, шее, груди, геморрагии на слизистой оболочке рото- и носоглотки, конъюнктивах; нередко ДВС-синдром

Кровоизлияния связаны прежде всего с тромбоцитопенией: риск кровоизлияний в жизненно важные органы появляется при числе тромбоцитов **менее 100 × 10^9**, реальная угроза — **менее 50 × 10^9**.

Степени тяжести

Признак	Лёгкая	Среднетяжёлая	Тяжёлая
Температура тела	**не выше 38,5 °C**, может быть нормальной	**38,5–39,5 °C**	**выше 39,5 °C**
Интоксикация	слабо или умеренно выражена	умеренно или сильно выражена: озноб, головная боль, миалгия, адинамия, рвота	ярко выражена, энцефалическая или менингоэнцефалическая реакция
Геморрагический синдром	отсутствует	носовые кровотечения, петехиальная сыпь — умеренно и кратковременно	носовые кровотечения, сыпь, геморрагии на слизистых оболочках, кровохарканье, гематурия, нередко ДВС-синдром

Осложнения со стороны респираторного тракта

1. острый стенозирующий ларинготрахеит — развивается в первые часы на фоне гипертермии и интоксикации, особенно у детей с респираторным аллергозом и ларингитом в анамнезе;
2. острый бронхит (20–30% случаев), у каждого пятого ребёнка — с обструктивным синдромом;
3. пневмония: в первые 4–5 дней — диффузная вирусная с тяжёлой гипоксемией и ОРДС; в конце первой — начале второй недели — вирусно-бактериальная, после короткого светлого промежутка.

Поражения ЛОР-органов (отит, евстахиит, синусит и др.) развиваются с участием бактериальной микрофлоры на любом этапе заболевания. Возможны невриты, преимущественно лицевого и тройничного нервов.

Наиболее тяжёлые осложнения (токсикоз с полиорганным поражением)

1. инфекционно-токсическая энцефалопатия (нейротоксикоз);
2. ОРДС;
3. синдром Гассера, острая почечная недостаточность;
4. синдром Рея;
5. миокардит и синдром Кишша;
6. синдром Уотерхауса — Фридериксена;
7. ДВС-синдром.

Примерно в 3–5% случаев, преимущественно при шифтовом варианте вируса, возможно внезапное ухудшение на любой день болезни, даже на фоне улучшения.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: острое начало, высокая стойкая лихорадка с первых часов, интоксикация; контакт с больным гриппом или ОРВИ, с инфицированными животными или птицами;
2. физикального обследования: умеренный или скудный катаральный синдром (ринофарингит, ларингит, трахеит), лихорадка, возможен геморрагический синдром;
3. подтверждения одним из лабораторных методов этиологической диагностики.

Подтверждённым считается случай после лабораторного подтверждения; в период эпидемического подъёма окончательный диагноз может быть установлен и по клиническим и эпидемиологическим данным.

3.2 Этиологическая диагностика

Иммунохроматографический экспресс-тест носоглоточного мазка на вирусы гриппа A и B — для ранней диагностики на амбулаторном и стационарном этапах; чувствительность 73,7–86,8%, специфичность 97,6–100%. Особенно актуален при невозможности ПЦР.

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) мазка со слизистой оболочки ротоглотки на вирус гриппа является стандартом диагностики; чаще используется при госпитализации.

Для дифференциальной диагностики и выявления сочетанных инфекций проводят ПЦР мазков носо- и ротоглотки на другие респираторные вирусы.

1. SARS-CoV-2 и сезонные коронавирусы;
2. вирусы парагриппа;
3. риновирусы и аденовирусы;
4. респираторно-синцитиальный вирус;
5. бокавирусы и метапневмовирусы.

Кому

1. всем госпитализированным;
2. амбулаторно — при тяжёлом течении, осложнениях, факторах риска.

Серологическая диагностика (ИФА) применяется ретроспективно при четырёхкратном нарастании титров специфических IgG, а также в научных и эпидемиологических целях.

3.3 Лабораторные исследования

Общий анализ крови показан при среднетяжёлом и тяжёлом гриппе.

1. **лейкопения** — прогностически неблагоприятна: высокий риск вирусной пневмонии
2. **лейкоцитоз с нейтрофилёзом и сдвигом влево** — высокий риск вирусно-бактериальной пневмонии и других бактериальных осложнений
3. **тяжёлое течение** — лейкоциты **более 12 × 10^9/л** или **менее 3 × 10^9/л**, незрелых форм нейтрофилов более 10%
4. **снижение гемоглобина и тромбоцитов** — требует исключить синдром Гассера; панцитопения — гемофагоцитарный синдром

При подозрении на бактериальные осложнения или микст-инфекцию исследуют СРБ и прокальцитонин: диагностическим считают повышение более чем на 2 стандартных отклонения; одновременное повышение обоих показателей точнее выявляет вторичную бактериальную пневмонию.

Общий анализ мочи — при подозрении на поражение почек.

Биохимический анализ крови — при тяжёлом или негладком течении: мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, билирубин, КФК, глюкоза; позволяет диагностировать рабдомиолиз, синдром Рея, кардиальные осложнения.

Коагулограмма — при геморрагических проявлениях для диагностики ДВС-синдрома; **натрий, калий, хлориды** — при тяжёлом течении: синдром Гассера, электролитные нарушения при обезвоживании.

3.4 Инструментальные исследования

Пульсоксиметрия выполняется на всех этапах помощи при подозрении на поражение нижних дыхательных путей, осложнённом течении, дыхательной недостаточности.

При подозрении на пневмонию выполняют рентгенографию лёгких или КТ органов грудной клетки; при подозрении на вирусную пневмонию (двусторонняя пневмония в первые 4 суток) предпочтительна КТ.

1. **ЭКГ** — при подозрении на поражение сердца, нарушения ритма и проводимости
2. **эхокардиография** — при сопутствующей кардиологической патологии
3. **ЭЭГ** — при неврологической симптоматике: судорогах, подозрении на отёк мозга, менингит, энцефалит

При подозрении на поражение органов показаны консультации кардиолога, невролога, оториноларинголога; при тяжёлом течении и осложнениях — осмотр анестезиолога-реаниматолога для своевременного перевода в отделение реанимации.

---

4. Лечение

4.1 Этиотропная терапия

Противовирусные препараты начинают **в первые 48 часов** после манифестации всем пациентам с симптомами гриппа.

1. основание — клиническое подозрение в сезон подъёма заболеваемости или контакт с больным гриппом;
2. лабораторного подтверждения не дожидаются;
3. вакцинация в текущем сезоне и тяжесть болезни на решение не влияют;
4. при тяжёлом течении и факторах риска терапию начинают на любом этапе разгара болезни.

Ингибиторы нейраминидазы — осельтамивир и занамивир — показаны при тяжёлом гриппе, среднетяжёлом с осложнённым течением и детям из групп риска при любой тяжести. При частом применении формируется резистентность.

1. осельтамивир: **с 1 года**;
2. #осельтамивир детям **старше 14 дней и младше 1 года**: при лабораторно подтверждённом тяжёлом или осложнённом гриппе 3 мг/кг на приём 2 раза в сутки по решению консилиума и с согласия законного представителя;
3. занамивир: **старше 5 лет** при тяжёлом гриппе, **в первые 36 часов**; с осторожностью при бронхоспазме.

Осельтамивир и занамивир не рекомендуются как препараты первой линии при лёгком и среднетяжёлом гриппе у детей без преморбидной патологии и факторов риска: это предотвращает формирование резистентности.

Препараты при неосложнённом гриппе без факторов риска

1. балоксавир марбоксил: однократно внутрь, при массе тела **от 20 кг**, в том числе в группах риска;
2. умифеновир: **с 2 лет** (порошок для суспензии), таблетки **с 3 лет**, капсулы **с 6 лет**.

1. Кагоцел: **старше 3 лет**;
2. имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты: **с 3 лет**, начать желательно не позднее 2-го дня болезни;
3. инозин пранобекс: **с 3 лет**.

Римантадин не рекомендуется при любой тяжести гриппа: доказана резистентность большинства штаммов.

4.2 Патогенетическая и симптоматическая терапия

Инфузионная терапия растворами электролитов и углеводов проводится при неэффективности оральной регидратации у детей с тяжёлым гриппом, стойкой лихорадкой, выраженной интоксикацией.

Объём рассчитывают по физиологической потребности и патологическим потерям: избыток жидкости, особенно изотонического раствора натрия хлорида, опасен отёком лёгких и мозга.

При фебрильной лихорадке применяют парацетамол или ибупрофен; при судорогах в анамнезе или на фоне болезни снижают и субфебрильную температуру.

1. парацетамол: суспензия **с 3 месяцев**, таблетки **с 3 лет**;
2. ибупрофен: суспензия **с 3 месяцев**, таблетки 200 мг **с 6 лет**, 400 мг **с 12 лет**.

При затруднённом дыхании и выраженном рините применяют деконгестанты и другие назальные препараты: они уменьшают отёк слизистой оболочки полости носа и улучшают отток из околоносовых пазух.

1. **сухой навязчивый кашель** — бутамират; возрастные ограничения зависят от лекарственной формы
2. **трахеит, бронхит, пневмония** — амброксол для облегчения отхождения мокроты

Одновременное применение отхаркивающих и противокашлевых препаратов не рекомендуется.

4.3 Иное лечение

При лёгком гриппе без факторов риска, подозрении на сочетанную вирусную инфекцию или признаках лёгкого иммунодефицита возможно применение иммуностимуляторов.

1. интерферон альфа-2b: с первых дней жизни, в том числе недоношенным, в ректальных суппозиториях;
2. меглюмина акридонацетат: **с 4 лет**;
3. Анаферон детский: **с 1 месяца**; Эргоферон: **с 6 месяцев**.

Антибактериальные препараты системного действия применяют только при вторичных бактериальных осложнениях, по клиническим рекомендациям соответствующих нозологий и с учётом чувствительности возбудителя.

Осложнения вирусно-бактериальной этиологии

1. синусит;
2. тонзиллит;
3. отит;
4. пневмония;
5. инфекция мочевыводящих путей.

При пневмонии, развившейся **с 5-х суток** гриппа, антибиотик назначают и без выделения возбудителя.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Диспансерное наблюдение при неосложнённом гриппе не показано. Больного изолируют дома, в изоляторе или боксе до клинического выздоровления; проводят влажную уборку и проветривание, выделяют отдельную посуду, ухаживающие моют руки и носят маски. Карантин для контактных не вводится.

Вакцинация проводится всем, не имеющим противопоказаний, в предэпидемический период; по национальному календарю прививают детей **с 6 месяцев**.

Вакцину против гриппа можно вводить с любым интервалом до или после других неживых и живых вакцин, кроме БЦЖ.

Непривитым в текущем сезоне детям после контакта с больным гриппом или ОРИ показана экстренная постконтактная химиопрофилактика; детям с факторами риска — обязательно.

1. ингибиторы нейраминидазы: если с контакта прошло **не более 48 часов**, только непривитым детям из группы риска;
2. балоксавир марбоксил: однократно **не позднее 48 часов** от контакта, при массе тела **от 20 кг**.

1. Кагоцел: **с 3 лет**; меглюмина акридонацетат: **старше 4 лет**; Анаферон детский: **с 1 месяца**;
2. интерферон альфа-2b интраназально: с первых дней жизни, 5 дней (мазь — старше 1 года); умифеновир — по инструкции.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. выраженная интоксикация;
2. геморрагический синдром, ДВС-синдром, синдром Гассера с острой почечной недостаточностью;
3. гемодинамическая нестабильность: холодные конечности, цианоз, мраморность кожи, коллапс, кома;
4. выраженная дыхательная недостаточность, признаки пневмонии и ОРДС;
5. новорождённые и дети первых лет жизни со среднетяжёлым осложнённым гриппом или обострением сопутствующих заболеваний.

Детей госпитализируют в инфекционные стационары, имеющие отделения реанимации и интенсивной терапии.

Критерии выписки

1. стабилизация состояния;
2. нормализация температуры.

Факторы риска неблагоприятного исхода

1. возраст **до 5 лет**, особенно **младше 2 лет**;
2. бронхиальная астма, пороки развития бронхолёгочной системы, муковисцидоз;
3. пороки и воспалительные заболевания сердца;
4. сахарный диабет, ожирение;
5. заболевания печени и почек, наследственные и митохондриальные нарушения обмена;
6. ВИЧ-инфекция, врождённые и приобретённые иммунодефициты;
7. неврологические нарушения.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Грипп»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.07.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	249_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Первая рекомендация раздела 3.1.1 предписывает ингибиторы нейраминидазы в первые 48 часов «всем пациентам с симптомами гриппа», а следующая не рекомендует осельтамивир и занамивир как препараты первой линии при лёгком и среднетяжёлом гриппе без факторов риска.
- Единицы измерения в разделах 1.6 и 2.3: тромбоциты «100 × 10^9/мл» (вместо /л), билирубин «более 50 ммоль/л» и креатинин «более 0,2 мг/л» — значения в указанных единицах физиологически невозможны.

Клинические рекомендации

Деформация перегородки носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J34.2** — Смещенная носовая перегородка
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.05.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/913_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Деформация перегородки носа: смещение перегородки от средней линии с нарушением носового дыхания. Основной жалобой является стойкое одно- или двустороннее затруднение носового дыхания.
- Диагноз устанавливается по жалобам, данным передней риноскопии и эндоскопии полости носа. Перед операцией выполняется рентгенография или КТ околоносовых пазух, детям и подросткам — КТ.
- Лечение хирургическое: септопластика, в том числе эндоскопическая. У детей из-за ростковых зон соблюдается щадящий подход.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Деформация перегородки носа: анатомическое изменение строения и положения перегородки относительно средней линии, вызывающее нарушение носового дыхания. Синонимы: девиация, искривление перегородки носа.

2.2 Этиология

Деформация перегородки носа без участия травмирующего агента может сформироваться вследствие дисбаланса развития в пренатальном периоде, при прохождении по родовым путям, а также в периоды активного роста, когда костно-хрящевой остов перегородки растёт быстрее, чем кости свода и дна полости носа.

Деформация может сформироваться и вследствие травмы; вид деформации при этом зависит от вида и механизма травмы. У детей этиология деформации преимущественно нетравматическая.

2.3 Классификация

Рекомендуемая унифицированная классификация:

1. С-образная девиация;
2. S-образное искривление;
3. гребень;
4. вывих четырёхугольного хряща;
5. утолщение («бугор»).

Известны также классификации Cottle, Mladina, А. С. Лопатина и Г. З. Пискунова.

2.4 Клиническая картина

Перегородка смещена от средней линии, изменена её форма. Основной симптом — одно- или двустороннее затруднение носового дыхания.

Возможные сопутствующие симптомы

1. гипо- или аносмия;
2. храп, апноэ сна;
3. ксеростомия, сухость слизистой носа;
4. деформация наружного носа;
5. рецидивирующие носовые кровотечения;
6. рецидивирующие риносинуситы;
7. стекание слизи по задней стенке глотки;
8. закрытая гнусавость;
9. рецидивирующая головная боль по типу головной боли напряжения.

---

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. жалобы на стойкое одно- или двустороннее нарушение носового дыхания;
2. передняя риноскопия: девиация и смещение перегородки, изменение внутриносовой анатомии, субтотальная или тотальная назальная обструкция;
3. эндоскопия полости носа, рентгенография или КТ околоносовых пазух: деформация перегородки и других внутриносовых структур.

У детей без сформированной речи затруднение носового дыхания оценивают со слов родителей или опекуна.

3.1 Передняя риноскопия

Выполняется всем пациентам с затруднением носового дыхания при первичном осмотре оториноларинголога.

Оценивают

1. перегородку и её положение;
2. нижние и средние носовые раковины;
3. состояние слизистой оболочки.

Лабораторные и иные исследования для первичной диагностики не показаны.

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Выполняется всем пациентам при наличии оборудования: показывает локализацию деформации, изменения других внутриносовых структур и состояние носоглотки.

3.3 Рентгенография или КТ околоносовых пазух

Показания

1. деформация перегородки: анатомия пазух, планирование операции, сопутствующая патология — хронический синусит, новообразования, инородные тела.

Детям и подросткам перед операцией — КТ околоносовых пазух обязательно.

4. Лечение

4.1 Хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению

1. стойкое затруднение носового дыхания, вызванное деформацией перегородки носа;
2. деформация подтверждена риноскопией или эндоскопией полости носа и носоглотки;
3. деформация подтверждена рентгенографией или КТ околоносовых пазух.

Методом лечения является септопластика или пластика перегородки носа с эндоскопической поддержкой; её цель состоит в восстановлении носового дыхания.

Дети и подростки

1. щадящий подход: минимальная резекция, бережность в проекции сфенодорсальной и сфеноостевой ростковых зон;
2. избыточная резекция в передних отделах и повреждение ростковых зон ведут к деформации наружного носа и средней трети лица;
3. интраоперационно — эндоскопическая или микроскопическая визуализация;
4. хирургическое лечение детей **младше 12 лет** возможно в учреждениях третьего уровня.

Риносептопластика, в том числе эндоскопическая, совместно с пластическим хирургом

1. выраженная деформация перегородки и костей носа;
2. выраженное каудальное искривление;
3. деформация в верхних отделах перегородки;
4. высокий риск неудовлетворительного результата или неполной коррекции при септопластике.

4.2 Послеоперационное ведение

Отсасывание слизи из носа: всем пациентам для очищения носовых ходов от фибрина, слизи и крови и профилактики синехий.

Септальные шины: по индивидуальным показаниям для профилактики синехий.

Препараты для улучшения носового дыхания, кратковременно: ксилометазолин, фенилэфрин, оксиметазолин, в том числе в комбинациях. Дозы по инструкции.

Орошение полости носа: всем пациентам солевыми растворами или стерильной морской водой для удаления фибрина и отделяемого. По индивидуальным показаниям возможны другие препараты.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Плановая госпитализация показана для хирургического лечения; показания к нему приведены в разделе «Хирургическое лечение».

Показания у детей

1. стойкое одно- или двустороннее затруднение дыхания и (или) апноэ сна, не связанные с другими причинами, со слов родителей;
2. деформация подтверждена эндоскопией полости носа и носоглотки и КТ околоносовых пазух.

Выписка

1. нет гнойного воспаления в полости носа;
2. нет местных и системных осложнений.

5.2 Наблюдение и профилактика

Конкретных рекомендаций о наблюдении нет; по клиническому опыту — плановые осмотры **в течение первого года** после операции. Медицинская реабилитация не показана.

Профилактика у детей

1. социальные меры по профилактике травматизма: безопасный досуг детей и подростков, безопасность дорожного движения;
2. разъяснительная работа с родителями в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях: возможность сопутствующих заболеваний и необходимость своевременного хирургического лечения.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Деформация перегородки носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 20.05.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее мая 2028 года
Код в рубрикаторе	913_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Дистония

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**G24** — Дистония **G24.0** — Дистония, вызванная лекарственными средствами **G24.1** — Идиопатическая семейная дистония **G24.2** — Идиопатическая несемейная дистония **G24.3** — Спастическая кривошея **G24.4** — Идиопатическая рото-лицевая дистония **G24.5** — Блефароспазм **G24.8** — Прочие дистонии **G24.9** — Дистония неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Всероссийское общество неврологов; Межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"; Национальная ассоциация детских реабилитологов; Межрегиональная общественная организация «Общество специалистов по функциональной и стереотаксической нейрохирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/867_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Дистония — двигательное расстройство со стойкими или нерегулярными мышечными сокращениями, которые обусловливают патологические, как правило повторяющиеся, движения и/или позы. Обычно проявляется или усиливается при произвольных движениях.
- **Ларингеальная дистония**
  1. пограничная проблема между ларингологией (фониатрией) и неврологией;
  2. осиплость, прерывистый, сдавленный, «лающий» голос; шёпотная речь часто нормальная, при пении дисфонии может не быть;
  3. аддукторная форма — в 90% случаев, абдукторная — менее 10%;
  4. нарушение дыхания (прерывистое, сдавленное) иногда ошибочно расценивают как бронхиальную астму.
- Для дифференциальной диагностики ларингеальной дистонии с другими заболеваниями гортани предлагается фониатрическое и фониоскопическое исследование с визуализацией всех структур гортани.
- При спастической аддукторной дисфонии применяют #ботулинический токсин типа А: он снижает частоту прерывания голоса и тяжесть спазма. Инъекции вводят под электромиографическим и ларингоскопическим контролем; препараты могут вводить только специалисты со специальной подготовкой.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Дистония — двигательное расстройство, характеризующееся стойкими или нерегулярными мышечными сокращениями, обусловливающими появление патологических, как правило повторяющихся, движений и/или патологических поз.

Эти движения и позы нарушают определённые действия в вовлечённых областях тела. Дистонические движения, как правило, однотипны и имеют вращательный характер, могут проявляться тремором.

2.2 Этиология и эпидемиология

Причина может быть обусловлена врождёнными и наследственными факторами или быть следствием заболеваний нервной системы; наследование — аутосомно-доминантное или аутосомно-рецессивное. В подавляющем большинстве случаев этиология остаётся невыясненной. Дистония занимает 3-е место среди двигательных расстройств.

2.3 Классификация

Формы по вовлечению областей тела

1. фокальная — одна область: блефароспазм, оромандибулярная, цервикальная, ларингеальная дистония, писчий спазм;
2. сегментарная — две и более смежные области (краниальная дистония);
3. мультифокальная — две и более несмежные области;
4. генерализованная — туловище и как минимум две другие области;
5. гемидистония — несколько областей с одной стороны.

2.4 Клиническая картина

Оромандибулярная дистония

1. непроизвольное открывание и/или закрывание рта, сжимание челюстей (дистонический тризм);
2. искривление губ, щёк, непроизвольные движения языка;
3. насильственная улыбка, особенно при речи и жевании;
4. корригирующие жесты: прикосновение к нижней половине лица, прикусывание губы, жевание предметов.

Начинается, как правило, в зрелом и пожилом возрасте; триггером может стать массивное стоматологическое лечение с протезированием.

Ларингеальная дистония — одно из наиболее тяжёлых нарушений голоса с напряжённо-сдавленной, прерывистой фонацией. Спазмы усиливаются при речевой нагрузке, эмоциональном напряжении, утомлении.

1. **аддукторная форма (90%)** — гиперактивность мышц-аддукторов голосовой щели: mm. cricothyroideus, cricoarytenoideus lateralis, interarytenoideus
2. **абдукторная форма (менее 10%)** — гиперактивность m. cricoarytenoideus posterior
3. **смешанные формы** — встречаются ещё реже

Характерно нарушение дыхания из-за нарушения прохождения воздуха через гортань; во время речи и пения дыхание обычно улучшается (парадоксальная кинезия).

Фарингеальная дистония проявляется затруднением глотания, чаще твёрдой пищи, и периодическим чувством «кома в горле» при глотании и/или в покое; часто сочетается с ларингеальной или оромандибулярной дистонией.

---

3. Диагностика

3.1 Клиническая диагностика

Дистонию диагностируют по особой неестественной (дистонической) позе, с тремором или без него.

Специфичные признаки

1. избыточные движения;
2. зеркальные движения;
3. корригирующие жесты.

Насильственные движения оценивают в покое и при нагрузке; оценивают и немоторные симптомы: боль, эмоциональные нарушения, расстройства сна.

Генетическое тестирование проводят только после клинической постановки диагноза.

3.2 Дифференциальная диагностика

1. **оромандибулярная дистония** — бруксизм, разные виды тризма, тики, миофасциальный синдром жевательных мышц с мышечно-суставной дисфункцией, поздняя нейролептическая и спонтанная орофациальная дискинезия
2. **ларингеальная дистония** — другие заболевания гортани — фониатрическое и фониоскопическое исследование с визуализацией всех структур гортани

4. Лечение

4.1 Ботулинотерапия

При спастической аддукторной дисфонии применяют #ботулинический токсин типа А и #ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс.

Цель

1. снижение частоты прерывания голоса;
2. снижение тяжести спазма;
3. увеличение периода фонаторного потока.

Диагноз в исследованиях устанавливала междисциплинарная группа: логопед, оториноларинголог, невролог.

Препарат вводили под электромиографическим и ларингоскопическим контролем; стандартные односторонние (50 ЕД) и двусторонние (по 25 ЕД с каждой стороны) инъекции в тироаритеноидные мышцы сравнивались у 50 пациентов.

Курсы инъекций повторяют **3–4 раза в год**; препараты ботулинического токсина вводят только специалисты со специальной подготовкой и опытом. После процедуры пациент **в течение часа** находится под наблюдением в лечебном учреждении для контроля немедленных аллергических реакций.

4.2 Хирургическое лечение

При генерализации дистонии и неэффективности лекарственного лечения проводится глубокая стимуляция мозга (у детей **с 7 лет**).

4.3 Медицинская реабилитация

Пациентам 18 лет и старше рекомендуется мультидисциплинарная программа реабилитации в стационаре: физическая терапия, кинезиотерапия, профессиональная переориентация, логопедические занятия, психотерапия.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Плановая госпитализация

1. хирургическое вмешательство: глубокая стимуляция мозга, микроваскулярная декомпрессия корешка VII пары при гемифациальном спазме;
2. ботулинотерапия при тяжёлых формах, требующих наблюдения в стационаре;
3. комбинированное лечение.

Экстренная госпитализация

1. осложнения дистонии;
2. осложнения лечения.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Дистония»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	867_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии; Ассоциация нейрохирургов России и др.
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В комментарии к рекомендации о ботулинотерапии спастической аддукторной дисфонии место введения названо «каждую щитоподъязычную мышцу», а далее в том же комментарии сравниваются инъекции в тироаритеноидные (щиточерпаловидные) мышцы — при аддукторной дисфонии препарат вводят в щиточерпаловидную мышцу.

Клинические рекомендации

Дифференцированный рак щитовидной железы

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C73** — Злокачественное новообразование щитовидной железы **D44.0** — Щитовидной железы
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 07.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов; Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Ассоциации эндокринных хирургов; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/329_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Дифференцированный рак щитовидной железы — злокачественная опухоль из фолликулярных клеток, сохраняющих признаки дифференцировки. Специфической клиники не имеет и, как правило, проявляется как узловой зоб.
- **Оториноларингологу**
  1. всем пациентам с раком щитовидной железы или подозрением на него до операции выполняется видеоларингоскопия для оценки подвижности голосовых складок, независимо от субъективной оценки голоса;
  2. при невозможности — УЗИ голосовых складок;
  3. при подозрительных ультразвуковых признаках узла — УЗИ гортани для исключения инвазии в гортань и пареза голосовой складки из-за вовлечения возвратного гортанного нерва.
- **ТАБ по системе EU-TIRADS**
  1. EU-TIRADS 3: узлы **2,0 см и более**;
  2. EU-TIRADS 4: **1,5 см и более**;
  3. EU-TIRADS 5: **1,0 см и более**;
  4. узлы **менее 1 см**: только при факторах риска — повышенный кальцитонин, увеличенные узлы, облучение головы и шеи, паралич голосовой складки, возраст до 18 лет.
- При IV, V и VI категории цитологического заключения по Bethesda показано хирургическое лечение; объём — от гемитиреоидэктомии при опухоли до 4 см без инвазии и метастазов до тиреоидэктомии при опухоли более 4 см, экстратиреоидной инвазии или метастазах.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Дифференцированный рак щитовидной железы — злокачественная опухоль из фолликулярных клеток щитовидной железы, сохраняющих присущие им признаки дифференцировки.

2.2 Этиология и эпидемиология

Основными факторами развития являются мутации генов (BRAF, PTEN, RAS, TERT и др.), воздействие ионизирующего излучения, наследственные синдромы (Гарднера, Каудена, множественной эндокринной неоплазии 2А и 2В типа).

В 2021 г. рак щитовидной железы составил 2,16% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями; средний возраст пациентов — 54 года. Стандартизированная заболеваемость — 6,14 на 100 тыс. населения, смертность — 0,32 на 100 тыс.

2.3 Классификация

Первичная опухоль (T), AJCC 8-е изд.

1. **T1a** — опухоль **менее 1 см**, ограниченная тканью железы
2. **T1b** — **более 1, но менее 2 см**
3. **T2** — **более 2, но не более 4 см**
4. **T3a** — **более 4 см**, ограниченная тканью железы
5. **T3b** — любого размера с макроскопическим распространением за капсулу с инвазией только в подподъязычные мышцы
6. **T4a** — распространение на подкожные мягкие ткани, гортань, трахею, пищевод, возвратный нерв
7. **T4b** — распространение на предпозвоночную фасцию, сосуды средостения или оболочку сонной артерии

Группировка дифференцированного рака по стадиям

Стадия	До 55 лет	55 лет и старше
I	любое T, любое N, M0	T1–T2 N0/Nx M0
II	любое T, любое N, M1	T1–T2 N1 M0; T3a/b любое N M0
III	—	T4a любое N M0
IVA / IVB	—	T4b любое N M0 / любое T, любое N, M1

2.4 Клиническая картина

Дифференцированный рак не имеет специфической клинической картины и, как правило, проявляет себя как узловой зоб. Анапластический рак проявляется быстро растущим образованием на передней поверхности шеи; позже присоединяются нарушения дыхания и глотания, увеличение регионарных лимфатических узлов.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

До операции диагноз устанавливается по результатам цитологического исследования пунктатов щитовидной железы, изменённых лимфатических узлов шеи и смывов из иглы на тиреоглобулин; после операции — по плановому патолого-анатомическому исследованию.

3.2 Жалобы и анамнез

Факторы высокого риска при узловом зобе

1. семейный анамнез рака щитовидной железы;
2. облучение головы и шеи в анамнезе;
3. дисфагия, дисфония;
4. узлы, случайно выявленные при ПЭТ с флудезоксиглюкозой;
5. операции по поводу рака щитовидной железы в анамнезе.

3.3 Физикальное обследование

Обращают внимание на изменение контуров шеи, узловое образование в щитовидной железе, увеличение регионарных лимфатических узлов, изменение голоса.

3.4 Лабораторные исследования

При узловом образовании исследуют кальцитонин крови — для исключения медуллярного рака, и тиреотропный гормон. Повышение базального кальцитонина **более 100 пг/мл** крайне подозрительно в отношении медуллярного рака.

Дооперационное исследование тиреоглобулина у первичных пациентов с узлами не рекомендовано: на этом этапе он не является маркером рака.

3.5 УЗИ щитовидной железы и шеи

Подозрительные ультразвуковые признаки узла

1. гипоэхогенная солидная структура;
2. неровный, нечёткий или полициклический контур;
3. точечные гиперэхогенные включения (микрокальцинаты);
4. преобладание переднезаднего размера над шириной («выше, чем шире»).

3.6 Оценка гортани

Всем пациентам с раком щитовидной железы или подозрением на него на дооперационном этапе, независимо от субъективной оценки голосовой функции, выполняется видеоларингоскопия для объективной оценки подвижности голосовых складок; при невозможности — УЗИ голосовых складок.

При подозрительных ультразвуковых признаках узла выполняется УЗИ гортани — для исключения инвазии опухоли в гортань и/или пареза голосовой складки вследствие вовлечения возвратного гортанного нерва.

3.7 Тонкоигольная аспирационная биопсия

ТАБ под ультразвуковым контролем является основным методом дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных поражений щитовидной железы и лимфатических узлов.

Показания определяются категорией EU-TIRADS и размером узла; при узлах менее 1 см вне группы риска агрессивных форм ТАБ нецелесообразна независимо от ультразвуковых характеристик.

Срочное направление на биопсию в специализированный центр

1. солидный гипоэхогенный узел, быстро увеличивающийся в размерах (**более 1 см в месяц**);
2. без болевого синдрома и кистозной трансформации;
3. особенно при затруднении дыхания, нарушении голоса или глотания.

Наиболее быстро растущими новообразованиями щитовидной железы являются анапластический рак и лимфома.

Цитологическая классификация Bethesda

1. I — неинформативная пункция;
2. II — доброкачественное образование;
3. III — атипия неопределённого значения;
4. IV — фолликулярная неоплазия или подозрение на неё;
5. V — подозрение на злокачественную опухоль;
6. VI — злокачественная опухоль.

КТ шеи и органов грудной полости с контрастированием выполняется при опухоли Т3–4, подозрении на экстратиреоидное распространение, изменённых регионарных лимфатических узлах по данным УЗИ.

4. Лечение

4.1 Показания к операции по цитологии

1. **Bethesda IV, V, VI** — хирургическое лечение
2. **Bethesda III** — повторная пункция для уточнения риска злокачественности

4.2 Объём операции

Объём операции по размеру и распространённости опухоли

Ситуация	Объём операции
интратиреоидная опухоль менее 1,0 см (IV–VI)	гемитиреоидэктомия; альтернатива по выбору пациента — активное наблюдение с экспертным УЗИ 1 раз в полгода
V–VI, 1–4 см, без экстратиреоидной инвазии и метастазов (cN0)	гемитиреоидэктомия или тиреоидэктомия
V–VI, более 4 см, выраженная экстратиреоидная инвазия (cT3), cN1 или M1	тиреоидэктомия с максимальной хирургической абляцией опухолевой ткани

1. **центральная зона (VI уровень)** — удаление — при подозрении на метастазы до или во время операции
2. **профилактическая центральная лимфаденэктомия** — при T3–4 или верифицированных метастазах в боковой клетчатке шеи
3. **II–V уровни** — только при доказанном по ТАБ метастатическом поражении; селективное удаление узлов вне футлярно-фасциального блока неадекватно

4.3 Стратификация риска и радиойодтерапия

Низкий риск — радиойодтерапия обычно не показана

1. нет локорегионарных и отдалённых метастазов;
2. удалена вся опухолевая ткань;
3. нет экстратиреоидной и сосудистой инвазии, неагрессивный гистологический вариант;
4. нестимулированный тиреоглобулин **1 нг/мл и менее** **через 6–12 недель** после тиреоидэктомии.

Промежуточный риск — радиойодтерапия индивидуально

1. агрессивный гистологический вариант;
2. поражение более 5 лимфатических узлов, сосудистая инвазия, положительный край резекции;
3. нестимулированный тиреоглобулин **до 10 нг/мл** **через 6–12 недель**.

Высокий риск — абсолютные показания к радиойодтерапии

1. резидуальная опухоль;
2. метастатический узел **более 3 см**;
3. макроскопическая экстратиреоидная инвазия;
4. широко инвазивный фолликулярный рак, подозрение на отдалённые метастазы;
5. нестимулированный тиреоглобулин **более 10 нг/мл**.

Для подготовки к радиойодтерапии без тиротропина альфа левотироксин натрия отменяют **за 3–4 недели**; проводится 2-недельная диета с низким содержанием йода, после рентгеноконтрастных исследований натрия йодид [^{131}I] не назначают **в течение 2 месяцев**.

4.4 Терапия левотироксином натрия

Целевые уровни ТТГ

1. супрессивная терапия: ТТГ **менее 0,1 мЕд/л**;
2. мягкая супрессия: **0,1–0,5 мЕд/л**;
3. заместительная терапия: **0,4–4,0 мЕд/л**.

В группе низкого риска и при биохимической ремиссии супрессивная терапия не рекомендуется — проводится заместительная.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Динамическая стратификация риска

1. **биохимическая ремиссия** — УЗИ без изменений, нестимулированный тиреоглобулин **менее 0,2 нг/мл**; вероятность рецидива 1–4%
2. **биохимический рецидив** — нестимулированный тиреоглобулин **более 1 нг/мл**, стимулированный **более 10 нг/мл**, вираж антител к тиреоглобулину
3. **структурный рецидив** — структурные или функциональные признаки опухоли при любой концентрации тиреоглобулина

После операции УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желёз и лимфатических узлов шеи выполняется **через 6–12 месяцев** в зависимости от группы риска и динамики тиреоглобулина. При подозрительных узлах **более 0,8–1,0 см** — прицельная ТАБ с определением тиреоглобулина в смыве из иглы.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная или неотложная госпитализация

1. осложнения онкологического заболевания;
2. осложнения лечения.

Плановая госпитализация

1. сложные интервенционные диагностические вмешательства;
2. специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в стационаре.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Дифференцированный рак щитовидной железы»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	329_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Российское общество клинической онкологии; Российская ассоциация эндокринологов и др.
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.

Клинические рекомендации

Доброкачественные образования головы и шеи

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D10.0** — Губы **D10.1** — Языка **D10.2** — Дна полости рта **D10.3** — Других и неуточненных частей рта **D11.0** — Околоушной слюнной железы **D11.7** — Других больших слюнных желез **D11.9** — Большой слюнной железы неуточненное **D13.0** — Пищевода **D14.0** — Среднего уха, полости носа и придаточных пазух **D16.0** — Лопатки и длинных костей верхней конечности **D17.0** — Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки головы, лица и шеи **D18.0** — Гемангиома любой локализации **D18.1** — Лимфангиома любой локализации **D19.0** — Мезотелиальной ткани плевры **D21.0** — Соединительной и других мягких тканей головы, лица и шеи **D22.0** — Меланоформный невус губы **D23.0** — Кожи губы **D23.1** — Кожи века, включая спайку век **D23.2** — Кожи уха и наружного слухового прохода **D23.3** — Кожи других и неуточненных частей лица **D23.4** — Кожи волосистой части головы и шеи **D36.0** — Лимфатических узлов **D36.7** — Других уточненных локализаций **D36.9** — Доброкачественное новообразование неуточненной локализации
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/842_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Доброкачественная опухоль: новообразование с медленным ростом, без метастазирования и без рецидива после полного удаления; клетки высокодифференцированы и нечувствительны к лучевому воздействию.
- **Диагноз устанавливают по совокупности**
  1. образование головы или шеи, выявленное при физикальном и инструментальном обследовании;
  2. исключение другой патологии со схожей клинической картиной;
  3. заключение гистологического исследования.
- **Основа обследования**
  1. УЗИ слюнных желёз и (или) лимфатических узлов при любом объёмном образовании головы и шеи;
  2. МРТ или КТ мягких тканей с контрастированием, если образование занимает несколько анатомических областей или имеет полость;
  3. пункция под контролем УЗИ для дифференциальной диагностики;
  4. морфологическое исследование любого образования.
- При подозрении на сосудистое образование выполняют дуплексное сканирование сосудов, а от предоперационной биопсии отказываются из-за риска кровотечения.
- Основной метод лечения хирургический. Консервативное лечение допустимо только при воспалении отдельных форм, чтобы затем оперировать в плановом порядке; при сосудистых образованиях возможны склеротерапия и другие нехирургические методы.
- Неотложная госпитализация требуется при присоединении воспаления (кистозные образования) и при обильном, профузном, продолжающемся кровотечении (сосудистые опухоли).

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Опухолью называют избыточную ненормальную массу ткани, которая возникает в результате чрезмерного неконтролируемого клеточного роста, сохраняющегося даже после прекращения влияния вызвавших его факторов (R. Willis).

1. **эксцизионная биопсия** — забор для исследования патологического образования целиком
2. **инцизионная биопсия** — забор части образования либо диффузно изменённого органа
3. **органоспецифические опухоли** — характерны для определённого органа и его специфических структур
4. **органонеспецифические опухоли** — не имеют типичной органной локализации

2.2 Этиология и эпидемиология

Патогенез доброкачественных опухолей основан на нарушении механизмов контроля деления и роста клеток, а также механизмов апоптоза. К предрасполагающим факторам относят механическую или термическую травму, вирусы, эндокринные нарушения. Опухолеподобные образования и пороки развития формируются вследствие нарушения развития I и II жаберных дуг и щелей, глоточных карманов или эмбриогенеза сосудистой и лимфатической системы.

Новообразования и опухолеподобные процессы полости рта и челюстно-лицевой области составляют около 20–25% опухолевых заболеваний. Среди доброкачественных опухолей слизистой оболочки полости рта чаще всего встречается папиллома (41,3%), обычно на языке и щеке. Врождённые кисты и свищи составляют около 5% новообразований лица и челюстей; аномалии жаберных щелей встречаются чаще тиреоглоссальных (61 и 39%).

2.3 Классификация

Виды доброкачественных новообразований

1. истинные опухоли;
2. опухолеподобные образования;
3. кисты.

Классификация ВОЗ (2017): кисты и кистоподобные поражения

1. бранхиогенные кисты;
2. киста щитовидного протока;
3. ранула;
4. дермоидные и тератоидные кисты.

Доброкачественные опухоли ЛОР-локализаций по ВОЗ

1. **полость носа, пазухи и основание черепа** — папилломы пазух различного типа, гамартома
2. **носоглотка** — волосатый полип, эктопическая аденома гипофиза, краниофарингиома, ангиофиброма носоглотки, хордома
3. **гортаноглотка, гортань, трахея и парафарингеальное пространство** — папилломы, плоскоклеточная папиллома, кондилома, мультифокальная гиперплазия эпителия, веррукозная лейкоплакия
4. **слюнные железы** — плеоморфная аденома, эпителиоидная гемангиоэндотелиома

Внеорганные опухоли шеи по Г. В. Фалилееву (1970)

1. **нейроэктодермального происхождения** — невринома (неврилеммома), нейрофиброма, ганглионеврома, менингиома, хемодектома каротидная и блуждающего нерва
2. **из производных мезенхимы** — фиброма, десмоид, липома, синовиома, гемангиома, лимфангиома, миома, лейомиома, рабдомиома
3. **дисэмбриональные** — срединная киста шеи, боковая киста шеи, хордома, тимома, тератома

Международная морфологическая классификация

1. **органоспецифические одонтогенные** — амелобластома, одонтома, одонтогенная фиброма, эпулис, цементома, остеобластокластома
2. **органоспецифические опухоли слюнных желёз** — аденома, аденолимфома, смешанная опухоль, киста, мукоэпидермальная опухоль, ангиома, лимфангиома, липома, невринома, нейрофиброматоз
3. **органоспецифические опухоли слизистой оболочки полости рта** — папиллома, фиброма, фиброматоз, миксома, гемангиома, лимфангиома, липома, нейрофиброма
4. **органонеспецифические остеогенные** — остеома, хондрома, оссифицирующая фиброма
5. **органонеспецифические неостеогенные** — гемангиома, гемангиоэндотелиома, хондрома, миксома, нейрофиброма, нейрофиброматоз

2.4 Клиническая картина

Жалобы зависят от вида, локализации и размеров образования. При небольших размерах заболевание долго протекает бессимптомно; при поверхностном расположении пациента беспокоят эстетический дефект, асимметрия лица или само образование.

При увеличении образования или определённой локализации

1. чувство инородного тела;
2. дисфагия, затруднённое глотание;
3. ограничение движений языка или шеи;
4. затруднённое открывание рта.

Как правило, жалобы носят местный характер, общее состояние не страдает. При воспалении кист и кистоподобных образований возникают боль, повышение температуры тела, лихорадка. При отдельных видах образований возможно периодическое кровотечение.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз доброкачественного образования головы и шеи

1. наличие образования головы или шеи по данным физикального и инструментального обследования, предпринятого после анализа жалоб;
2. исключение другой патологии со схожей клинической картиной;
3. заключение гистологического исследования.

3.2 Жалобы и анамнез

Что уточняют при сборе анамнеза

1. начало заболевания, появление первых симптомов и сроки увеличения образования;
2. боль в области образования и нарушение функции;
3. этиологические факторы, которые можно устранить, чтобы снизить риск рецидива.

Быстрое развитие заболевания может указывать на озлокачествление образования. При переходе воспаления на окружающие ткани появляются общие симптомы, которые затрудняют диагностику и меняют алгоритм лечения.

3.3 Физикальное обследование

Помимо общего осмотра, осматривают само образование и окружающие ткани; осмотр проводят в стоматологическом кресле.

Признаки, которые оценивают

1. размер, форма, чёткость краёв, цвет;
2. спаянность с окружающими тканями, плотность, болезненность при пальпации;
3. инфильтрация подлежащих тканей;
4. расположение относительно сосудов и нервов.

Функции, которые оценивают

1. глотание и речь;
2. движения глазного яблока, мимика;
3. слух;
4. повороты головы и открывание рта.

Нарушение функции бывает патогномоничным: так, срединная киста шеи смещается по средней линии при глотании. Нарушения функций могут осложнить анестезиологическое пособие и требуют привлечения специалистов смежных дисциплин.

3.4 Лабораторные исследования

Перед началом лечения

1. общий (клинический) анализ крови развёрнутый;
2. биохимический общетерапевтический анализ крови, в том числе билирубин, АЛТ и АСТ;
3. коагулограмма с протромбиновым временем, МНО, АЧТВ и фибриногеном;
4. общий (клинический) анализ мочи.

3.5 УЗИ слюнных желёз и лимфатических узлов

Показания

1. любое объёмное образование головы и шеи;
2. оценка регионарных лимфатических узлов.

Диагностические признаки

1. послойная дифференцировка мягких тканей;
2. эхоструктура образования;
3. характер и тип кровотока.

Эффективность УЗИ в выявлении образований шеи составляет 70–90%; картина кистозных образований зависит от нозологической формы.

3.6 Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области

При сосудистых опухолях дуплексное сканирование определяет объём и локализацию образования и его возможный сосудистый компонент.

3.7 МРТ или КТ мягких тканей с контрастированием

Показания

1. образование занимает несколько анатомических областей;
2. наличие полости;
3. уточнение соотношения с окружающими тканями и сосудисто-нервным пучком.

Исследование выполняют **до тонкоигольной аспирационной биопсии**, чтобы пункция не изменила картину образования. По гомогенности, структуре и контурам опухоли при МРТ доброкачественный и злокачественный рост удаётся различить в 90% случаев.

При артериовенозных, капиллярных и венозных мальформациях значительного размера целесообразна КТ-ангиография. Сочетание МРТ и МР-ангиографии различает низкоскоростные и высокоскоростные сосудистые мальформации, а при обширных поражениях исключает или подтверждает вовлечение внутричерепных структур.

3.8 Пункция мягких тканей под контролем УЗИ

Пункцию мягких тканей под контролем УЗИ и пункцию гнойного очага выполняют при образованиях с кодами D10.3, D11, D17.0, D36 для дифференциальной диагностики и выбора методики операции.

Успешны около 80% исследований. Цитологическое заключение об отсутствии опухоли нельзя считать окончательным, так как материал при тонкоигольной биопсии бывает скудным; заключение о наличии опухоли окончательно всегда.

3.9 Патологоанатомическое исследование

Биопсийный (операционный) материал опухолей и опухолеподобных образований мягких тканей исследуют **при малом размере — во время операции**, **при значительном — до операции**. Исследование включает макроскопическое изучение и микроскопию с окрашиванием, в том числе гистохимическими методами.

При подозрении на сосудистое образование от предоперационной биопсии отказываются из-за риска кровотечения.

3.10 КТ-фистулография

При боковых, околоушных и срединных свищах при наличии технической возможности выполняют КТ-фистулографию: она определяет локализацию, длину и ход свищевого канала.

---

4. Лечение

4.1 Хирургическое лечение

Оценка до лечения (челюстно-лицевой хирург)

1. размер образования и его отношение к окружающим органам;
2. результаты биопсии и визуализации (КТ, МРТ) для оценки распространения;
3. текущий функциональный статус и возможность хирургического лечения.

Вид вмешательства при новообразованиях мягких тканей с кодами D10, D11, D17.0 выбирают тщательно, чтобы снизить риск рецидива. Анестезиологическое пособие подбирают с учётом размеров и локализации образования и его соотношения с органами.

С учётом эстетических запросов пациента опухоли мягких тканей головы и шеи удаляют с использованием видеоэндоскопических технологий: в исследовании (n=65) малоинвазивные эндоскопически ассоциированные вмешательства значительно улучшили эстетические и функциональные результаты в эстетически ценных областях.

Для восстановления эстетики и социализации пациента выполняют резекцию черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой.

Реконструктивно-восстановительные операции по оперативно-техническим приёмам

1. **I группа** — местно-пластические операции тканями, прилежащими к дефекту
2. **II группа** — пластика лоскутами на питающих ножках при обширных и объёмных дефектах
3. **III группа** — аутотрансплантация свободного лоскута с формированием сосудистых анастомозов при сложных обширных дефектах
4. **IV группа** — дистракционный остеогенез при дефектах и недоразвитии костей лицевого черепа
5. **V группа** — лицевое эндопротезирование имплантатами
6. **VI группа** — эктопротезирование: оральные и экстраоральные протезы, протезы уха и носа

4.2 Сосудистые новообразования

Методику удаления сосудистого новообразования выбирают по размеру и локализации, чтобы исключить рецидив. Удаление является основным радикальным методом, особенно при ангиомах небольшого размера: иссечение со сближением краёв раны редко даёт рецидив.

При увеличении размеров образования

1. перевязка приводящих и отводящих сосудов;
2. удаление с пластикой дефекта;
3. при значительном прорастании — реконструктивно-пластические операции: свободный лоскут с сосудистыми анастомозами, резекция лицевых костей, замещение дефекта костным аллотрансплантатом.

Нехирургические методы (только при сосудистых образованиях)

1. склерозирующая терапия;
2. криодеструкция;
3. лазерная терапия;
4. электрохимический лизис;
5. эндоваскулярная терапия.

Частота положительных результатов достигала 84,2% при хирургическом лечении, 81,8% при эндоваскулярной терапии и 96,9% при комбинированном лечении: мультидисциплинарный подход эффективнее.

При низкоскоростных сосудистых опухолях проводят склеротерапию, чтобы по возможности избежать операции.

Препараты

1. #этанол 70%;
2. лауромакрогол 400;
3. натрия тетрадецилсульфат.

Склерозант вводят транскутанно в просвет сосуда, контролируя положение кончика иглы флюороскопией с одновременным введением водорастворимого низкоосмолярного рентгеноконтрастного средства. Повреждение эндотелия ведёт к облитерации сосудов и снижению кровотока в образовании.

4.3 Консервативное лечение

Консервативное лечение рассматривают только при воспалении отдельных форм образований (рубрики D10.2–D10.3, D11 и D23.3–D23.4), чтобы затем оперировать в плановом порядке. Оно состоит из стандартной противовоспалительной и симптоматической терапии.

4.4 Медицинская реабилитация

Всем пациентам после хирургического лечения проводят многоэтапную реабилитацию для полного социального и физического восстановления.

Чем обусловлена необходимость реабилитации

1. операционная травма мягких тканей головы и шеи;
2. риск гнойно-септических осложнений и послеоперационных кровотечений;
3. болевой синдром;
4. нарушения глотания, мимики, открывания рта, движений языка и речи.

1-й этап: ранняя реабилитация в стационаре

1. контроль гемостаза и раневого процесса;
2. купирование послеоперационного болевого синдрома, противоотёчная терапия;
3. ежедневная санация ран растворами антисептиков;
4. консультация медицинского психолога.

2-й этап: с 15-х по 45-е сутки после операции

1. физиотерапия после получения гистологического ответа — для восстановления функции и улучшения вида рубца;
2. лечебная физкультура для восстановления функционального статуса.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Всем пациентам с подозрением на доброкачественное образование головы и шеи необходимы ранняя диагностика и лечение для снижения риска малигнизации.

В информации для пациента указано диспансерное наблюдение **раз в 6 месяцев** **в течение 1 года** с проведением УЗИ.

1. **неотложная госпитализация** — присоединение воспаления (кистозные образования), обильное, профузное и продолжающееся кровотечение (сосудистые опухоли)
2. **плановая госпитализация** — образование без воспаления окружающих тканей

Диагностику в плановой ситуации проводят амбулаторно. Операции выполняют в специализированных отделениях, где возможны малоинвазивные вмешательства; некоторые вмешательства допустимы амбулаторно или в дневном стационаре.

Критерии выписки после неотложной госпитализации

1. уменьшение местных проявлений воспаления;
2. болевой синдром купируется препаратами в амбулаторных условиях;
3. нет признаков кровотечения, постгеморрагическую анемию можно корригировать амбулаторно.

Критерии выписки после плановой операции

1. неосложнённое течение раннего послеоперационного периода;
2. нет гнойно-септических осложнений раневого процесса;
3. болевой синдром контролируется пероральными препаратами;
4. пациент может продолжить лечение амбулаторно под наблюдением врача.

Факторы, ухудшающие исход

1. инфекционные осложнения;
2. нарушение функциональных и эстетических качеств;
3. несоблюдение послеоперационного режима и рекомендаций.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Доброкачественные образования головы и шеи»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 18.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	842_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Диспансерное наблюдение раз в 6 месяцев в течение года с УЗИ указано только в информации для пациента (приложение В); в разделе 5 «Профилактика и диспансерное наблюдение» сроки наблюдения не приводятся.
- Первый критерий качества — «Выполнено дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области» — сформулирован для всех пациентов, тогда как в разделе 2.4 исследование рекомендовано только при сосудистых опухолях.

Клинические рекомендации

Доброкачественные остео- и хондрогенные опухоли носа и пазух

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D14.0** — Среднего уха, полости носа и придаточных пазух
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/756_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Доброкачественные костные и хрящевые опухоли носа и околоносовых пазух:
  1. остеома;
  2. остеобластома;
  3. фиброзная дисплазия;
  4. аневризматическая костная киста;
  5. оссифицирующая фиброма;
  6. гигантоклеточная опухоль;
  7. хондрома и другие хрящевые опухоли.

  Наиболее часто встречается остеома лобной пазухи.
- Стойкий или прогрессирующий на фоне лечения односторонний воспалительный процесс в полости носа и пазухах требует исключения опухоли: показаны КТ носа и околоносовых пазух, при необходимости биопсия.
- Диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, осмотра, эндоскопии полости носа и КТ носа и околоносовых пазух.
- Лечение хирургическое. При небольшой бессимптомной остеоме допустима выжидательная тактика. После операции выполняется контрольная КТ через **3–6 месяцев**, затем через **1 год и более**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Опухоли

Опухоль	Определение
Остеома	медленно растущая (0,44–6,0 мм в год) опухоль из костной ткани; случаев малигнизации не описано
Остеобластома	редкая опухоль из костной ткани, продуцирующая ретикуло-фиброзные перекладины, окружённые крупными остеобластами
Фиброзная дисплазия	опухолевидное поражение: разрушение костной ткани с деформацией и заполнением костномозгового канала фиброзной тканью
Аневризматическая костная киста	редкое заболевание кости с локальным деструктивным и экспансивным ростом
Оссифицирующая фиброма	опухоль из кальцификатов, цемента, костной и фиброзной ткани; ювенильная форма течёт агрессивнее
Гигантоклеточная опухоль (остеокластома)	редкое новообразование кости с локально-агрессивным, деструктивным ростом
Хондрома	истинная опухоль из хрящевой ткани с длительным развитием: от 3 месяцев до 10 лет
Хондромиксоидная фиброма	редкая опухоль из веретеновидных или звёздчатых клеток в миксоидной или хондроидной строме
Хондробластома	редкая опухоль из хондробластов

Опухоль	Определение
Носовая хондромезенхимальная гамартома	опухоль из веретенообразных клеток, хрящевой ткани и геморрагических кист

2.2 Этиология

Причины окончательно не установлены. К возможным факторам риска относятся нарушение эмбриогенеза, инфекция, травма; при фиброзной дисплазии основную роль играет мутация гена GNAS1.

2.3 Классификация

Общепринятой классификации нет; классификации отдельных опухолей рабочие и учитываются при планировании лечения.

Рабочие классификации

1. остеома по строению: компактная, губчатая, смешанная;
2. остеобластома по скорости роста: латентная, активная, агрессивная;
3. фиброзная дисплазия: монооссальная (70–85%) и полиоссальная (15–30%);
4. аневризматическая костная киста, фазы: остеолиз, отграничение, восстановление;
5. хондрома: энхондрома (внутри кости) и экхондрома (на поверхности кости).

2.4 Клиническая картина

Жалобы, как правило, связаны с ростом опухоли, её давлением на стенки пазух и (или) распространением на смежные области. Опухоли небольших размеров обычно не сопровождаются жалобами и могут быть случайной находкой при рентгенологическом обследовании.

Частые жалобы

1. головная боль в носо-лицевой области, в проекции пазухи;
2. заложенность носа, аносмия — при обтурации соустья, вторичном синусите, мукоцеле;
3. рецидивирующие носовые кровотечения — при аневризматической костной кисте;
4. асимметрия и безболезненный отёк лица — при фиброзной дисплазии;
5. головная боль, нарушение зрения, тригеминальная гиперчувствительность, парез глазных мышц — при гигантоклеточной опухоли клиновидной кости.

Распространение на орбиту и в полость черепа

1. деформация носоглазничной области, проптоз, периорбитальная боль, хемоз, диплопия, периорбитальная эмфизема;
2. слезотечение — при сдавлении носослёзного канала;
3. снижение зрения — при сдавлении зрительного нерва;
4. общемозговые и очаговые симптомы, менингит, абсцесс мозга — при интракраниальном распространении.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается по жалобам, анамнезу, физикальным данным, эндоскопической ревизии полости носа и носоглотки и КТ носа и околоносовых пазух.

Симптомы неспецифичны и в начале заболевания минимальны. Выраженная клиническая картина отсутствует в 4–10% случаев остеомы, а случайно эта опухоль обнаруживается при КТ у 1–3% обследованных.

3.1 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. сроки, последовательность и динамику жалоб;
2. прежние травмы и заболевания носа и пазух, их лечение и эффект;
3. результаты прежних обследований: анализы, КТ, МРТ, биопсия, протоколы операций;
4. похожие жалобы у близких родственников.

3.2 Осмотр

Общий осмотр, пальпация и перкуссия носо-лицевой области, пальпация подчелюстных, подподбородочных и глубоких шейных лимфоузлов. Для доброкачественных опухолей изменения регионарных лимфоузлов не характерны.

3.3 Передняя риноскопия и видеориноскопия

Выполняется всем пациентам.

Оценивают

1. преддверие носа и передние отделы слизистой оболочки полости носа;
2. нижнюю и среднюю носовые раковины, перегородку носа;
3. наличие и характер отделяемого в носовых ходах;
4. новообразование в передних отделах полости носа или распространяющееся туда из глубоких отделов, обтурирующее полость носа.

Видеориноскопия риноскопом или фиброскопом показана всем пациентам. Первичный осмотр целесообразно выполнять без подготовки полости носа и анестезии.

3.4 Компьютерная томография носа и околоносовых пазух

Показания

1. подозрение на опухоль носа и околоносовых пазух: КТ от плоскости твёрдого нёба до верхней границы лобной пазухи, толщина среза **2 мм**.

Оценивают

1. локализацию, распространённость и размеры новообразования;
2. структуру новообразования;
3. кальцификацию;
4. ремоделирование прилежащей костной ткани.

Остеома на КТ

1. компактная: округлое плотное почти бесструктурное образование;
2. губчатая: грубо-трабекулярная структура;
3. смешанная: зона 300–600 ед. Н губчатого строения и зона более 800 ед. Н компактного вещества.

Фиброзная дисплазия на КТ — однородная ткань «матового стекла» плотностью около 300–450 ед. Н, не инкапсулирована; кистозная форма — с участками более низкой плотности.

Остеобластома на КТ — сочетание плотной кости и участков затемнения.

Хондрома на КТ — образование гетерогенной плотности с чёткими границами и очагами минерализации.

Остеохондрома на КТ — костное вещество неоднородной плотности в центре, ткань хрящевой плотности по периферии.

3.5 МРТ и консультации специалистов

МРТ и консультации челюстно-лицевого хирурга, офтальмолога, нейрохирурга позволяют выявить распространение опухоли на верхнюю челюсть, глазницу и в полость черепа.

Обязательны при

1. изменениях зубочелюстной системы: смещение, расшатывание, выпадение зубов, деформация;
2. глазных симптомах: проптоз, периорбитальная боль, хемоз, диплопия, слезотечение;
3. менингеальных и очаговых неврологических симптомах.

3.6 Биопсия

По показаниям выполняется биопсия и патологоанатомическое исследование с иммуногистохимией для дифференциальной диагностики доброкачественной и злокачественной опухоли.

Способы биопсии

1. прицельная биопсия под эндоскопом: материал берут на границе опухоли с неизменёнными тканями;
2. эксцизионная биопсия: при небольших размерах опухоли;
3. аспирационная биопсия иглой: при кистозном образовании, солидной опухоли;
4. цитологическое исследование отпечатка или мазка-отпечатка со слизистой оболочки: в отдельных случаях.

---

4. Лечение

Лечение хирургическое: эндоназальный, наружный или комбинированный доступ. Применение навигационного оборудования повышает эффективность и безопасность вмешательства.

Экстраназальные доступы при значительной распространённости опухоли

1. транспалатинный;
2. боковая ринотомия;
3. краниофациальная резекция;
4. срединный декортикационный доступ (midfacial degloving).

4.1 Остеома

Для удаления остеомы применяют эндоназальный (эндоскопический), наружный или комбинированный доступ; способ зависит от размеров опухоли и места её прикрепления к стенке пазухи. Наружный доступ более травматичен: возможны послеоперационный эстетический дефект, парестезии, прозопалгия.

При небольшой бессимптомной остеоме рекомендуется выжидательная тактика. По некоторым данным, к операции следует прибегать при остеоме, занимающей **более 50%** объёма пазухи. Рецидивы редки и возникают, как правило, через **5–8 лет**.

Классификация остеом лобной пазухи по A. G. Chiu, 2005

Степень	Остеома лобной пазухи
1	прикреплена сзади-снизу, медиальнее плоскости бумажной пластинки; переднезадний размер меньше 75% лобного кармана
2	то же расположение, переднезадний размер больше 75% лобного кармана
3	прикреплена спереди или сверху и (или) выходит латеральнее плоскости бумажной пластинки
4	полностью обтурирует лобную пазуху

Эндоскопическое удаление

1. предпочтительно при остеомах 1 и 2 степени, описано и успешное удаление 3 и 4 степени;
2. относительное ограничение: большие остеомы задне-верхних отделов лобной пазухи (из-за длительности вмешательства);
3. не показано при остеоме на передней и нижней стенке латеральных отделов лобной пазухи;
4. интраорбитальное и интракраниальное распространение не является абсолютным противопоказанием.

4.2 Фиброзная дисплазия

В связи с возможностью регресса рекомендуется выжидательная тактика с постоянным наблюдением и периодической КТ.

Показания к хирургическому лечению

1. выраженная костная деформация;
2. возраст пациента;
3. ограниченная распространённость изменений.

Медикаментозная терапия

1. бифосфонаты: профилактика патологических переломов и боли; существует риск остеонекроза челюсти;
2. при синдроме Мак-Кьюна — Олбрайта: терапия для купирования эндокринных нарушений.

Показания к эндоскопической хирургии

1. облегчение симптомов риносинусита, ассоциированного с фиброзной дисплазией;
2. декомпрессия зрительного нерва.

Эффективность декортикации стенок верхнечелюстной пазухи требует доказательств.

4.3 Другие опухоли

Лечение по виду опухоли

Опухоль	Лечение
Остеобластома	хирургическое удаление эндоназальным, наружным или комбинированным доступом с учётом локализации, размеров и места прикрепления опухоли
Аневризматическая костная киста	хирургическое удаление: от пункции полости кисты до кюретажа и резекции поражённого участка кости; предоперационная эмболизация питающих сосудов
Оссифицирующая фиброма	возможно более раннее и полное удаление: краниофациальная резекция, латеральная ринотомия, midfacial degloving или эндоскопическая диссекция; продолжительное послеоперационное наблюдение
Гигантоклеточная опухоль	хирургическое удаление; длительное динамическое наблюдение
Хондрома	хирургическое удаление из-за риска малигнизации и разрушения стенок; предпочтительно эндоскопическое удаление, а при распространении опухоли в верхнечелюстную пазуху и орбиту — гайморотомия по Денкеру
Хондромиксоидная фиброма	хирургическое удаление; предпочтительна широкая эксцизия эндоскопически или доступом midface degloving
Хондробластома	радикальное иссечение

4.4 Лучевая терапия

1. при гигантоклеточной опухоли лучевая терапия может быть рекомендована, если локализация ограничивает радикальное удаление или требует инвалидизирующего вмешательства;
2. при аневризматической костной кисте она возможна, но нежелательна из-за риска малигнизации (трансформации в саркому);
3. при оссифицирующей фиброме она оказалась неэффективной и потенциально опасна из-за вероятности малигнизации опухоли.

У остеобластомы описан случай малигнизации после лучевой терапии.

4.5 Рецидивы после удаления

1. остеобластома: после радикального удаления рецидивов нет в течение 5–15 лет; у детей частота рецидивов достигает 32%;
2. аневризматическая костная киста: рецидивы в 10–30% случаев, чаще в течение **первых двух лет**;
3. ювенильная оссифицирующая фиброма: до 30% даже при полном удалении, риск сохраняется до 18 лет;
4. гигантоклеточная опухоль: частота рецидивов зависит от распространённости, данных для носа и пазух нет;
5. хондромиксоидная фиброма: кюретаж эффективен в 80%; многократные рецидивы описаны и после радикальной операции; при иссечении единым блоком рецидивов меньше, но операция травматичнее;
6. хондробластома: при одном кюретаже рецидивы достигают 55%.

4.6 Хондрома: другие доступы

1. радикальное удаление распространённой хондромы носа и околоносовых пазух может быть затруднено осложнениями во время операции, в частности кровотечением;
2. в некоторых случаях при такой локализации прибегают к чрезнёбному или наружному (боковая ринотомия) доступу;
3. хондрому носовых костей можно успешно удалить доступом, используемым при наружной ринопластике.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализация

1. доброкачественная остео- или хондрогенная опухоль носа и пазух без противопоказаний к плановой операции.

Выписка

1. нет осложнений, удовлетворительное общее состояние.

5.2 Реабилитация и наблюдение

После удаления опухоли рекомендуется охранительный режим **10–14 дней и более**.

Специфической профилактики нет. После операции необходимо динамическое наблюдение: КТ **через 3–6 месяцев**, затем **через 1 год и более**, в зависимости от вида опухоли, локализации и радикальности операции.

Прогноз зависит от гистологии, локализации и распространённости. Радикальное удаление, как правило, приводит к излечению, однако из-за рецидивов и возможной малигнизации необходимо динамическое наблюдение.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Доброкачественные остеогенные и хондрогенные опухоли носа и околоносовых пазух»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 04.03.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее марта 2026 года
Код в рубрикаторе	756_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В критериях оценки качества уровни доказательности (КТ — УУР А, УДД 1; операция — А, 4; охранительный режим — В, 2) не совпадают с уровнями этих рекомендаций в тексте (С, 4–5).

Клинические рекомендации

Злокачественные новообразования губы

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C00** — Злокачественное новообразование губы
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/553_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рак губы исходит из эпителия красной каймы; в 85–90% случаев поражается нижняя губа, опухоль располагается несколько в стороне от срединной линии. Морфологическая верификация является обязательным критерием диагноза.
- Основным методом радикального лечения является хирургический, с одномоментной пластикой при необходимости. Дистанционная или внутритканевая лучевая терапия по радикальной программе — при отказе от операции или противопоказаниях к ней.
- **Лимфодиссекция при T1–T2 N0 по глубине инвазии**
  1. **менее 2 мм**: операция только на первичном очаге, шейная диссекция не рекомендуется;
  2. **2–4 мм**: решение индивидуально, возможна биопсия сторожевого узла;
  3. **более 4 мм**: операция и селективная лимфодиссекция, минимально уровни 1–3.
- Адекватным считается удаление с отступом от края резекции до видимой опухоли **1,5 см и более**; чистый край — **5 мм и более**, близкий — **менее 5 мм**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Рак губы — злокачественная опухоль из многослойного плоского эпителия красной каймы нижней или верхней губы. Поражение кожи и слизистой оболочки обусловлено дальнейшим распространением опухолевого процесса.

2.2 Этиология и эпидемиология

Этиологические факторы

1. неблагоприятные метеорологические факторы: длительная солнечная инсоляция, резкие колебания температуры;
2. курение, особенно в сочетании с крепким алкоголем, жевание смесей (насвай, орех бетель);
3. фоновые процессы: плоская лейкоплакия, эритроплакия, хронические язвы и трещины губ, хейлиты.

Мужчины болеют чаще женщин (3:1). В 2021 г. распространённость составила 22,5 на 100 тыс. населения, впервые диагноз установлен в 1881 случае; в 83,5% заболевание выявляется на I–II стадиях. Максимум заболеваемости — в возрасте 55–75 лет и старше.

2.3 Классификация

Распространённость оценивается по классификации TNM 8-го издания AJCC для эпителиальных опухолей полости рта; глубина инвазии не является толщиной опухоли.

Группировка по стадиям

Стадия	Сочетание T, N, M
0	Tis N0 M0
I	T1 N0 M0
II	T2 N0 M0
III	T3 N0 M0; T1–T3 N1 M0
IVA	T1–T3 N2 M0; T4a N0–N2 M0
IVB	любое T N3 M0; T4b любое N M0

Стадия	Сочетание T, N, M
IVC	любое T, любое N, M1

2.4 Клиническая картина

Опухоль обычно локализуется несколько в стороне от срединной линии, в углах рта возникает крайне редко; в 85–90% поражается нижняя губа.

1. **экзофитные формы (папиллярная, бородавчатая)** — развиваются на фоне продуктивного дискератоза, долго; опухоль имеет вид папилломы, множественных мелких выростов, цветной капусты
2. **эндофитные формы** — развиваются на фоне деструктивного дискератоза: уплотнение, трещина, эрозия или язва; появление по краям валикообразного венчика свидетельствует об озлокачествлении

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, физикального и инструментального обследования; морфологическая верификация является обязательным достоверным критерием диагноза.

3.2 Физикальное обследование

Осмотр включает бимануальную пальпацию очага и регионарных лимфатических узлов и оценку нутритивного статуса. Перед лечением выполняются общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, коагулограмма.

3.3 Инструментальные исследования

1. **УЗИ лимфатических узлов шеи** — всем, с пункцией пальпаторно неизменённых узлов
2. **УЗИ первичного очага** — всем — для определения толщины опухоли и планирования операции на лимфоколлекторах шеи

Всем выполняется КТ и/или МРТ поражённой области с внутривенным контрастированием — для оценки распространённости, глубины инвазии, костной инвазии на челюсти и основание черепа.

1. **КТ органов грудной полости** — при распространённом раке с поражением регионарных узлов; при невозможности — рентгенография лёгких
2. **сцинтиграфия костей** — при подозрении на метастазы в кости
3. **ПЭТ-КТ** — при III–IV стадиях — для исключения отдалённых метастазов

Морфологическое заключение отражает

1. размеры и распространённость первичной опухоли, глубину инвазии;
2. гистологическое строение и степень дифференцировки;
3. периваскулярную, перилимфатическую, периневральную инвазию;
4. статус регионарных узлов (pN) с числом исследованных и поражённых узлов, экстранодальное распространение (ENE);
5. расстояние до ближайшего края резекции в мм;
6. экспрессию PD-L1 — при нерезектабельном процессе и паллиативном лечении.

4. Лечение

4.1 Тактика лечения по стадиям

Хирургическое вмешательство является основным методом радикального лечения; удаление образования выполняют с одномоментной пластикой при необходимости. При Tis возможна мукозэктомия с применением физических методов: лазер, радиочастотная абляция, плазменная коагуляция, фотодинамическая терапия.

При отказе от операции или противопоказаниях

1. дистанционная лучевая терапия по радикальной программе;
2. внутритканевая лучевая терапия самостоятельно или в сочетании с ДЛТ;
3. фотодинамическая терапия.

При периневральной, периваскулярной, лимфатической инвазии в операционном материале показана адъювантная лучевая терапия; при положительном крае — повторная операция или ЛТ.

Тактика по стадиям

Стадия	Лечение
T1–T2 N0, глубина инвазии менее 2 мм	операция только на первичном очаге, шейная диссекция не рекомендуется
T1–T2 N0, глубина инвазии более 4 мм	операция на первичном очаге и селективная лимфодиссекция (минимально уровни 1–3); при 2–4 мм — индивидуально, возможна биопсия сторожевого узла
T3–T4a N0; T1–T4a N1–N3	операция на первичном очаге с шейной лимфаденэктомией; при невозможности операции — ДЛТ или ХЛТ, внутритканевая ЛТ в комбинации с ДЛТ/ХЛТ

Объём шейной лимфаденэктомии

1. **N0** — селективная на стороне поражения, уровни 1–3; не менее 18 удалённых узлов; при срединной опухоли или переходе за среднюю линию — с двух сторон
2. **N1, N2a–b, N3** — радикальная на стороне поражения, уровни 1–5; при срединной опухоли — дополнительно селективная с контралатеральной стороны, уровни 1–3
3. **N2c** — радикальная с двух сторон, уровни 1–5

При высокой вероятности или наличии метастазов в лимфатические узлы шеи выполняют профилактическую ипсилатеральную лимфаденэктомию; при срединной опухоли или переходе за среднюю линию — двустороннюю. При ранних стадиях рака губы метастазирование в узлы встречается редко, в среднем менее 10%.

Целью операции является статус R0. Адекватным считается отступ от края резекции до видимой опухоли **1,5 см и более** или отрицательный край замороженного среза; интраоперационное исследование срезов проводят, если свободная зона **менее 1,5 см** или граница опухоли нечёткая.

1. чистый край: **5 мм и более** от инвазивного края опухоли;
2. близкий край: **менее 5 мм**.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Физикальный осмотр и сбор жалоб

1. первый год: **каждые 1–3 месяца**;
2. второй год: **каждые 2–6 месяцев**;
3. 3–5-й год: **1 раз в 4–8 месяцев**;
4. после 5 лет: **ежегодно** или при жалобах.

Объём обследования

1. УЗИ лимфатических узлов шеи с двух сторон, органов брюшной полости и малого таза;
2. КТ головы и шеи — по показаниям и при недоступности зоны осмотру;
3. рентгенография или КТ органов грудной клетки — **каждые 12 месяцев**;
4. тиреотропный гормон после облучения шеи — **каждые 6–12 месяцев**.

Наблюдение у стоматолога показано до, во время и после специализированного лечения; проблемные зубы удаляют **не менее чем за 2 недели** до начала лечения.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная или неотложная госпитализация

1. осложнения онкологического заболевания;
2. осложнения лечения: хирургического, лучевого, лекарственного.

Плановая госпитализация

1. сложные интервенционные диагностические вмешательства;
2. специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в стационаре.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Злокачественные новообразования губы»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	553_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи; Российское общество клинической онкологии; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.

Клинические рекомендации

Злокачественные новообразования полости рта

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C02.0** — Спинки языка **C02.1** — Боковой поверхности языка **C02.2** — Нижней поверхности языка **C02.3** — Передних 2/3 языка неуточненной части **C02.8** — Поражение языка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций **C02.9** — Языка неуточненной части **C03** — Злокачественное новообразование десны **C04** — Злокачественное новообразование дна полости рта **C05.0** — Твердого неба **C06** — Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 16.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/164_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Раком слизистой оболочки полости рта называют злокачественную опухоль из плоскоклеточного эпителия слизистой оболочки щёк, нёба, дёсен, дна полости рта, языка; более 90% случаев — плоскоклеточный рак.
- Заподозрить рак следует при новообразовании, не поддающемся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**: безболезненном узелке, уплотнении, язве или трещине. Для верификации берут мазок-отпечаток, соскоб или биопсию.
- При T1–T2 N0 основным методом является операция; при местно-распространённых опухолях — операция с шейной лимфодиссекцией, затем ДЛТ или ХЛТ по неблагоприятным факторам. Операцию планируют, только если достижима резекция R0.
- **Лимфодиссекция по глубине инвазии опухоли**
  1. **менее 2 мм**: не показана;
  2. **2–4 мм**: индивидуально, возможна биопсия сторожевого узла;
  3. **более 4 мм**: ипсилатеральная селективная лимфодиссекция обязательна.
- Отступ от края инфильтрата при резекции — **1,5 см**; край препарата **менее 5 мм** от опухоли считается близким.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Рак слизистой оболочки полости рта — злокачественная опухоль, развивающаяся из элементов плоскоклеточного эпителия слизистой оболочки щёк, нёба, дёсен, дна ротовой полости, языка.

2.2 Этиология и эпидемиология

Этиологические факторы

1. курение, особенно в сочетании с крепким алкоголем, жевание смесей (орех бетель);
2. фоновые процессы: лейкоплакия, эритроплакия, хронические язвы и трещины губ, хейлиты;
3. хроническая инфекция в полости рта;
4. хроническая травматизация слизистой оболочки разрушенными зубами, корнями, некачественными протезами.

Распространённость — 6,52 на 100 000 населения; в 2021 г. в России зарегистрировано 9503 случая. Заболеваемость и смертность неуклонно растут.

2.3 Классификация

Более 90% злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта — плоскоклеточный рак, реже аденокарцинома из малых слюнных желёз и саркомы.

Степень дифференцировки: G1 — высокая, G2 — средняя, G3 — низкая.

Первичная опухоль (T) с учётом глубины инвазии (ГИ), TNM 8-е изд.

1. **Tis** — карцинома in situ
2. **T1** — **≤ 2 см** при ГИ **≤ 5 мм**
3. **T2** — **≤ 2 см** с ГИ **более 5 и ≤ 10 мм**; или **более 2 и ≤ 4 см** с ГИ **≤ 10 мм**
4. **T3** — **более 2 и ≤ 4 см** с ГИ **более 10 мм**; или **более 4 см** с ГИ **≤ 10 мм**
5. **T4a** — **более 4 см** с ГИ **более 10 мм**; прорастание только прилежащих тканей: кортикального слоя челюсти, верхнечелюстной пазухи, кожи лица
6. **T4b** — распространение на жевательный аппарат, крыловидные отростки, основание черепа и (или) охват сонной артерии

ГИ — глубина инвазии, а не общая толщина опухоли. Поверхностной эрозии кости или зубной лунки недостаточно для T4. Определения T2–T4a приведены в уточнённой редакции из текста КР.

Регионарные лимфатические узлы (cN)

1. **N1** — один узел на стороне поражения **менее 3 см**, без экстранодального распространения (ENE)
2. **N2** — один узел **более 3 и не более 6 см** (N2a), несколько на стороне поражения (N2b), с обеих или противоположной стороны (N2c) — до 6 см, ENE нет
3. **N3** — узел **более 6 см** без ENE (N3a) или метастаз любого размера с ENE (N3b)

Группировка по стадиям

Стадия	Сочетание T, N, M
0	Tis N0 M0
I	T1 N0 M0
II	T2 N0 M0
III	T1–T2 N1 M0; T3 N0–N1 M0
IVA	T1–T3 N2 M0; T4a N0–N2 M0
IVB	любое T N3 M0; T4b любое N M0
IVC	любое T, любое N, M1

2.4 Клиническая картина

1. **начальный период** — безболезненные узелки, уплотнения, поверхностные язвы или трещины, не поддающиеся консервативному лечению; жжение или покалывание при еде
2. **развитой период** — боль практически в 100% случаев, иррадиирует в ухо, височную область; зловонный запах изо рта при вторичной инфекции и распаде
3. **запущенный период** — массивное разрушение окружающих тканей с вовлечением костей, преддверия рта, кожи, мышц

Формы роста: экзофитная (грибовидные, бляшкообразные разрастания с чёткими границами), эндофитная (язва с опухолевым валиком или инфильтрат без чётких границ) и смешанная.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: новообразование, не поддающееся консервативному лечению **2–3 недели**;
2. осмотра и пальпации образования, прилежащих тканей и регионарных узлов;
3. цитологического исследования соскоба, мазков, пунктата опухоли и узлов;
4. патолого-анатомического исследования биопсийного материала;
5. УЗИ полости рта и шеи, КТ или МРТ, ПЭТ-КТ, фиброларингоскопии по показаниям.

3.2 Жалобы, анамнез и физикальное обследование

Перед лечением собирают жалобы и анамнез; осмотр включает бимануальную пальпацию очага и регионарных узлов и оценку нутритивного статуса. Перед лечением выполняют общий и биохимический анализы крови, коагулограмму, общий анализ мочи.

3.3 Цитологическое исследование и биопсия

При подозрении на рак до лечения берут мазки-отпечатки, соскоб или биопсию с поверхности эрозий, язв, трещин; уплотнения без изъязвления пунктируют тонкой иглой. При неясном результате цитологии выполняют биопсию с патолого-анатомическим и иммуногистохимическим исследованием.

1. **опухоль верифицирована** — определить гистологический тип и степень дифференцировки
2. **сомнительный результат** — обязательная повторная биопсия в объёме, достаточном для иммуногистохимии
3. **отрицательный результат** — повторная биопсия при убедительных клинических или рентгенологических признаках рака

3.4 КТ и МРТ лицевого черепа и шеи

Всем пациентам с верифицированным раком для оценки распространённости выполняют КТ и (или) МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием (от основания черепа до верхней апертуры грудной клетки).

1. **МРТ** — предпочтительна при симптомах вовлечения черепных нервов — оценка периневральной инвазии
2. **КТ** — информативнее для оценки деструкции кортикального слоя кости
3. **УЗИ тканей полости рта** — при артефактах от металлоконструкций зубных протезов

3.5 Стадирование: узлы и отдалённые метастазы

1. **УЗИ лимфатических узлов шеи** — всем; при признаках метастазов — биопсия узла под контролем УЗИ
2. **КТ органов грудной полости** — всем до лечения; при невозможности — рентгенография лёгких
3. **ПЭТ-КТ с ФДГ или КТ грудной и брюшной полостей** — при III–IV стадии или T1–T2 с N1 и более
4. **эзофагогастродуоденоскопия, фиброларингоскопия** — по показаниям

При III–IV стадии или T1–T2 с N1 и более и клиническом подозрении на метастазы в головной мозг выполняют МРТ головного мозга с контрастированием, при невозможности — КТ.

Для планирования лучевой терапии выполняют МРТ мягких тканей головы и шеи. Эффект ЛТ/ХЛТ оценивают по ПЭТ всего тела или МРТ с контрастированием **через 2–3 месяца** после окончания лечения. При нерезектабельной опухоли определяют экспрессию PD-L1 (TPS, CPS).

4. Лечение

4.1 Тактика лечения по стадиям

На первом этапе онколог, специализирующийся на опухолях головы и шеи

1. получает достаточный биопсийный материал;
2. оценивает распространённость опухоли и функциональное состояние;
3. исключает вторые опухоли полости рта и ротоглотки;
4. определяет хирургические опции.

Операция возможна, только если достижима резекция R0; лимфодиссекцию и реконструктивный этап планируют заранее.

Тактика по стадиям

Стадия	Лечение
T1–T2 N0	операция — основной метод; при противопоказаниях или отказе — ДЛТ или брахитерапия по радикальной программе
T3–T4a N0 M0	операция с ипсилатеральной или билатеральной (при центральном расположении или переходе за среднюю линию) шейной лимфодиссекцией
T1–T4a N1–N3 M0	операция с ипсилатеральной или билатеральной лимфодиссекцией; при противопоказаниях или отказе — ХЛТ
T4b, нерезектабельные N+ или противопоказания к операции	по ECOG: 0–1 — ХЛТ или индукционная ХТ с последующей ДЛТ/ХЛТ и решением вопроса об операции; 2 — ДЛТ ± ХТ; 3 — паллиативная ДЛТ, монохимиотерапия или паллиативная помощь

Тактика после операции по неблагоприятным прогностическим факторам (НПФ)

1. **pN0 без НПФ** — динамическое наблюдение
2. **pN1 без других НПФ** — реоперация до лимфодиссекции I–V уровней или послеоперационная ДЛТ
3. **pT3–4, периневральная, периваскулярная, перилимфатическая инвазия, pN2–3a** — послеоперационная ДЛТ; при 2 и более НПФ — рассмотреть ХЛТ
4. **только R1** — перерезекция, при невозможности — конкурентная ХЛТ
5. **ENE+ (pN3b)** — конкурентная ХЛТ

При местно-распространённой опухоли и угрозе кровотечения оценивают риск (изъязвление, полость, близость ветвей сонной артерии, незаживающая рана, состоявшееся кровотечение); при наличии риска выполняют ангиографию и суперселективную эмболизацию сосудов опухоли.

4.2 Хирургическое лечение

Признаки нерезектабельности (T4b)

1. вовлечение крыловидной мышцы или крылонёбной ямки: тризм, периферическая нейропатия;
2. распространение на основание черепа, в овальное отверстие;
3. распространение на верхние отделы и латеральную стенку носоглотки, устье слуховой трубы;
4. массивные метастазы на шее с распадом и вовлечением кожи;
5. распространение на медиастинальные узлы, превертебральную фасцию, шейный отдел позвоночника, магистральные сосуды; внутрикожные метастазы.

Ни один признак не является абсолютным противопоказанием: решающим служит возможность резекции R0.

Опухоль удаляют единым блоком с адекватным отступом; объём планируют по осмотру и лучевым исследованиям.

Резекция нижней челюсти

1. краевая или сегментарная — при инфильтрации альвеолярного края, неподвижности опухоли относительно челюсти, врастании по данным лучевых методов;
2. окончательный объём определяют интраоперационно;
3. при поражении канала нижнечелюстного нерва — сегментарная резекция.

Края резекции

1. рекомендуемый отступ от инфильтрата: **1,5 см**, не всегда выполним из-за магистральных сосудов;
2. чистый край: **5 мм и более**;
3. близкий край: **менее 5 мм**;
4. положительный край: опухолевые клетки по краю препарата.

Лимфодиссекция

1. **cN0** — селективная шейная лимфодиссекция I–III уровней
2. **cN+** — шейная лимфодиссекция I–V уровней: ипсилатеральная, при контралатеральном метастазе или срединной опухоли — билатеральная
3. **N2c** — радикальная лимфаденэктомия с двух сторон (I–V)

Главный предиктор метастазирования — глубина инвазии: **менее 2 мм** — лимфодиссекция не показана, **2–4 мм** — индивидуально или биопсия сторожевого узла, **более 4 мм** — ипсилатеральная селективная лимфодиссекция обязательна.

Биопсия сторожевого лимфатического узла — альтернатива селективной лимфодиссекции при T1–T2 с клинически неопределяемыми метастазами; эффективность метода — 95%. При метастазе в сторожевом узле выполняется лимфодиссекция I–V уровней, при его отсутствии лимфодиссекция не показана.

4.3 Лучевая и химиолучевая терапия

Самостоятельная ДЛТ (противопоказания к операции, нерезектабельность, отказ)

1. первичный очаг и клинически определяемые метастазы: 66–70 Гр по 2,0–2,2 Гр, 6–7 недель;
2. локорегионарная область с регионарными узлами: 46–54 Гр по 1,8–2,0 Гр;
3. при T1–T2 N0 альтернатива ДЛТ — брахитерапия в самостоятельном варианте.

При местно-распространённых опухолях без возможности операции проводится ХЛТ: ЛТ в тех же дозах с цисплатином 100 мг/м^2 на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни либо еженедельно 40 мг/м^2; суммарно 300 мг/м^2. При противопоказаниях к препаратам платины (СКФ менее 50–60 мл/мин, возраст старше 65 лет, ECOG более 1, тяжёлая сопутствующая патология) их заменяют цетуксимабом.

Послеоперационная ДЛТ показана при pT3–4 и N2–3, а также при pT1–2 N0–1 с неблагоприятными признаками; интервал после операции — **менее 6 недель**, не более 3 месяцев. Доза на ложе опухоли и метастазов — не менее 60 Гр при R0 и 66 Гр при R+. Послеоперационная ХЛТ проводится при ENE+ или R1/R2; при ENE− и R0 её рассматривают при двух и более неблагоприятных факторах.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

УЗИ лимфатических узлов шеи с двух сторон

1. первый год: **каждые 3 месяца**;
2. второй год: **каждые 3–6 месяцев**;
3. 3–5-й год: **1 раз в 6 месяцев**;
4. после 5 лет: **1 раз в год**.

Другие исследования

1. КТ органов грудной полости — **каждые 12 месяцев**;
2. УЗИ органов брюшной полости — по той же схеме, что УЗИ шеи;
3. КТ или МРТ головы и шеи — по клиническим показаниям и при невозможности адекватного осмотра;
4. при подозрении на рецидив — ПЭТ-КТ или КТ грудной и брюшной полостей.

Физикальный осмотр: во 2-й год — **каждые 2–6 месяцев**, на 3–5-й год — **1 раз в 4–8 месяцев**, после 5 лет — ежегодно или при жалобах. Тиреотропный гормон после облучения шеи — **каждые 6–12 месяцев**.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная или неотложная госпитализация

1. осложнения онкологического заболевания;
2. осложнения лечения: хирургического, лучевого, лекарственного.

Плановая госпитализация

1. сложные интервенционные диагностические вмешательства;
2. специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в стационаре.

Факторы прогноза

1. размеры и распространённость первичной опухоли;
2. глубина инвазии;
3. степень дифференцировки;
4. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
5. статус регионарных узлов (метастазы на шее вдвое снижают выживаемость), экстранодальное распространение;
6. статус краёв резекции.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Злокачественные новообразования полости рта»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 16.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	164_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи; Российское общество клинической онкологии; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице символа T для T2, T3 и T4a приведены по два определения: исходное и с пометкой «изменить на» — стадирование по глубине инвазии в тексте неоднозначно. На странице — уточнённая редакция.
- Периодичность физикального осмотра в первый год после лечения в разделе 5 указана как «каждые 13 мес» (вероятно, 1–3 месяца); УЗИ шеи в разделе 2.5.3 — каждые 3 месяца.

Клинические рекомендации

Злокачественные опухоли слюнных желёз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C06.9** — Рта неуточненное **C07** — Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы **C08** — Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.08.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/116_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Злокачественными опухолями слюнных желёз называют злокачественные новообразования слюнных желёз, различающиеся по морфологическому строению. Основную группу (95%) составляют эпителиальные опухоли; в 80–90% случаев они развиваются в больших слюнных железах.
- **Обследование при подозрении на злокачественную опухоль**
  1. УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов шеи;
  2. тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) первичной опухоли и подозрительных лимфатических узлов под контролем УЗИ с цитологическим исследованием;
  3. КТ органов грудной полости для исключения отдалённых метастазов;
  4. КТ или МРТ лицевого отдела черепа с контрастированием при подозрении на распространение на челюсти и основание черепа.
- Основным методом радикального лечения эпителиальных опухолей является хирургическое вмешательство; минимальный объём при подозрении на злокачественную опухоль околоушной железы — субтотальная резекция. Объём операции и послеоперационная лучевая терапия зависят от стадии и гистологии.
- При стадии T4b и невозможности радикальной операции проводится лучевая или одновременная химиолучевая терапия с учётом общего состояния.
- **Наблюдение после лечения**
  1. первые 1–2 года: **каждые 3–6 месяцев**;
  2. 3–5-й год: **1 раз в 6–12 месяцев**;
  3. после 5 лет: **ежегодно** или при появлении жалоб.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Определение КР охватывает злокачественные новообразования слюнных желёз разного морфологического строения. К большим слюнным железам относят околоушную, поднижнечелюстную и подъязычную.

2.2 Этиология и эпидемиология

Основные этиологические факторы

1. воспалительные заболевания;
2. алиментарные факторы;
3. гормональные и генетические нарушения;
4. курение.

Новообразования слюнных желёз составляют 1–5% всех злокачественных опухолей и 3% опухолей головы и шеи; пик заболеваемости приходится на возраст 15–39 лет. Эпителиальные опухоли в 80–90% случаев развиваются в больших слюнных железах, в 10% — в малых.

2.3 Классификация

Гистологическая классификация ВОЗ (5-е изд., 2022): злокачественные эпителиальные опухоли

1. мукоэпидермоидный рак;
2. аденокистозный рак;
3. ацинарноклеточная и секреторная карцинома;
4. полиморфная аденокарцинома;
5. протоковая карцинома слюнных желёз, миоэпителиальная и эпителиально-миоэпителиальная карцинома;
6. карцинома из плеоморфной аденомы, карциносаркома;
7. плоскоклеточный рак, лимфоэпителиальная карцинома;
8. другие (гиалинизирующая светлоклеточная, базальноклеточная, муцинозная, сальная аденокарцинома, сиалобластома и др.).

Классификация включает также неопухолевые эпителиальные поражения и доброкачественные опухоли (плеоморфная аденома, опухоль Уортина, онкоцитома и другие).

Степень злокачественности

1. **трёхступенчатая (высоко-, умеренно-, низкодифференцированная)** — мукоэпидермоидный рак, полиморфная аденокарцинома, аденокарцинома БДУ, плоскоклеточный рак
2. **двухступенчатая (low/high grade)** — внутрипротоковая карцинома
3. **аденокистозный рак** — указывается доля солидного компонента; более 30% солидных структур ассоциировано с агрессивным течением

Течение по гистотипу

1. **индолентное** — секреторная, микросекреторная карцинома, базальноклеточная и склерозирующая микрокистозная аденокарцинома, лимфоэпителиальная карцинома, сиалобластома
2. **агрессивное** — протоковая карцинома, миоэпителиальная карцинома, карцинома из плеоморфной аденомы, карциносаркома

Первичная опухоль (T), TNM 8-е изд.

1. **T1** — **2 см или менее**, без распространения за пределы паренхимы железы
2. **T2** — **более 2 см, но не более 4 см**, без распространения за пределы паренхимы
3. **T3** — **более 4 см** и (или) распространение за пределы паренхимы
4. **T4a** — распространение на кожу, нижнюю челюсть, слуховой проход и (или) лицевой нерв
5. **T4b** — распространение на крыловидные отростки, основание черепа или внутреннюю сонную артерию

Регионарные лимфатические узлы (cN)

1. **N1** — метастаз в одном узле на стороне поражения **3 см и менее**, без экстранодального распространения (ENE)
2. **N2** — метастаз в одном узле **более 3 см, но не более 6 см** (N2a), в нескольких узлах на стороне поражения (N2b), с обеих или противоположной стороны (N2c) — до 6 см, ENE отсутствует
3. **N3** — метастаз **более 6 см** без ENE (N3a) или любого размера с ENE

По данным планового патолого-анатомического исследования (pN) метастаз ≤ 3 см с ENE относится к N2a; метастазы с ENE в одном ипсилатеральном узле более 3 см, множественные или контралатеральные — к N3b.

Группировка по стадиям

Стадия	Сочетание T, N, M
I	T1 N0 M0

Стадия	Сочетание T, N, M
II	T2 N0 M0
III	T3 N0 M0; T1–T3 N1 M0
IVA	T1–T3 N2 M0; T4a N0–N2 M0
IVB	любое T N3 M0; T4b любое N M0
IVC	любое T, любое N, M1

2.4 Клиническая картина

Течение определяется локализацией, распространённостью и морфологическим строением. Как правило, опухоль имеет вид безболезненного узлового образования плотноэластической консистенции, не спаянного с кожей, подвижного при пальпации.

Признаки распространённого процесса

1. инфильтрация кожи;
2. ограничение смещаемости образования;
3. болезненность при пальпации;
4. парез мимической мускулатуры — крайне неблагоприятный прогностический признак.

Опухоль глоточного отростка околоушной железы снаружи не пальпируется: определяется лишь незначительная припухлость в околоушной области, а со стороны глотки — деформация её стенки. Опухоль растёт в сторону ротовой полости, кнаружи её распространению препятствует нижняя челюсть.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: наличие новообразования;
2. физикального обследования: осмотр, пальпация образования, прилежащих тканей и регионарных лимфатических узлов;
3. цитологического исследования материала ТАБ, трепан-биопсии, core-биопсии, инцизионной или эксцизионной биопсии;
4. патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала;
5. инструментальных исследований: УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ.

3.2 Жалобы и анамнез. Физикальное обследование

У всех пациентов тщательно собирают жалобы и анамнез, чтобы выявить факторы, влияющие на выбор тактики лечения.

Физикальный осмотр включает

1. осмотр и бимануальную пальпацию очага поражения;
2. пальпацию регионарных лимфатических узлов;
3. оценку нутритивного статуса.

3.3 УЗИ и тонкоигольная аспирационная биопсия

Всем пациентам с подозрением на злокачественную опухоль выполняют УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов шеи с ТАБ подозрительных узлов для верификации и определения распространённости.

ТАБ первичной опухоли и подозрительных лимфатических узлов под УЗИ-навигацией с цитологическим исследованием проводится всем пациентам: она отличает злокачественную опухоль от доброкачественной и уточняет распространённость.

Тактика по результату

1. **цитология неинформативна** — патолого-анатомическое исследование материала трепан-биопсии, core-биопсии, инцизионной или эксцизионной биопсии
2. **опухоль верифицирована** — определить гистологический тип и степень дифференцировки, если она применима к гистотипу
3. **сомнительный результат** — обязательная повторная биопсия в объёме, достаточном для иммуногистохимического исследования
4. **отрицательный результат** — повторная биопсия целесообразна при убедительных клинических или рентгенологических признаках злокачественной опухоли

3.4 КТ или МРТ лицевого отдела черепа

При местно-распространённом процессе и подозрении на распространение на нижнюю или верхнюю челюсть, основание черепа выполняется КТ или МРТ лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием.

3.5 КТ органов грудной полости

Выполняется всем пациентам со злокачественными опухолями слюнных желёз для исключения отдалённых метастазов.

3.6 ПЭТ всего тела

Позитронная эмиссионная томография всего тела с туморотропными радиофармпрепаратами уточняет распространённость при подозрении на отдалённые метастазы.

3.7 Патолого-анатомическое заключение

Параметры, которые отражаются в заключении

1. размер опухоли;
2. гистологический вариант;
3. степень дифференцировки или наличие high grade трансформации;
4. лимфоваскулярная и (или) периневральная инвазия;
5. pT;
6. pN с числом исследованных и поражённых узлов, экстранодальным распространением;
7. статус краёв резекции и минимальное расстояние от опухоли до края.

---

4. Лечение

4.1 Выбор метода лечения

Ниже приведены принципы лечения эпителиальных опухолей. Саркомы и лимфомы слюнных желёз лечат так же, как при других локализациях, по соответствующим клиническим рекомендациям.

Хирургическое вмешательство является основным методом радикального лечения. Минимальный объём операции при подозрении на злокачественную опухоль околоушной железы — субтотальная резекция околоушной железы.

Лечение по стадиям

Стадия	Лечение
T1–T2 N0	полное удаление первичной опухоли; послеоперационная ДЛТ при аденокистозном раке, низкодифференцированном мукоэпидермоидном раке, положительных краях, периневральной инвазии
T1–T2 N+ M0	удаление опухоли с шейной лимфаденэктомией, затем ДЛТ
T3–T4a N0 M0	полное удаление опухоли (при аденокистозном, протоковом раке и аденокарциноме — с шейной лимфаденэктомией), затем ДЛТ; при неблагоприятных гистологических признаках рассматривают одновременную ХЛТ
T3–T4a N+ M0	удаление опухоли с шейной лимфаденэктомией, затем ДЛТ; при неблагоприятных гистологических признаках рассматривают одновременную ХЛТ
T4b или невозможность радикальной операции	лучевая терапия или одновременная ХЛТ с учётом общего состояния; при невозможности радикального лечения — лекарственная терапия
Локорегионарный рецидив	полное удаление с решением вопроса о ЛТ или ХЛТ (после предшествующей ЛТ — о повторной); при неоперабельном рецидиве — ЛТ, ХЛТ или лекарственное лечение

Неблагоприятными гистологическими признаками считают низкодифференцированную опухоль, положительные края резекции, периневральную инвазию, сосудистую эмболию.

4.2 Хирургическое лечение

Перед лечением онколог, специализирующийся на опухолях головы и шеи

1. оценивает адекватность биопсийного материала, стадирования и визуализации (КТ, МРТ);
2. исключает синхронную первичную опухоль;
3. оценивает функциональный статус и возможность операции;
4. составляет план наблюдения: обследование зубов, питание, реабилитация.

Объём операции не уменьшают из-за регрессии опухоли до лечения; расширяют только при прогрессировании.

Признаки нерезектабельности (T4b)

1. значительное поражение крылонёбной ямки, тяжёлый тризм из-за инфильтрации крыловидных мышц;
2. макроскопическое распространение на основание черепа (эрозия крыловидных пластинок или основной кости, расширение овального отверстия);
3. охват общей или внутренней сонной артерии — **≥ 270° окружности** по КТ и МРТ;
4. распространение из лимфатических узлов на кожу, средостение, предпозвоночную фасцию или шейные позвонки.

Первичную опухоль по возможности удаляют единым блоком. Если опухоль прилежит к нерву, его выделяют и резецируют до чистого края под контролем срочного исследования замороженных срезов; предпочтительна одномоментная реконструкция нерва. Чистым считается край **≥ 5 мм** от инвазивного края опухоли, близким — **менее 5 мм**.

4.3 Лучевая терапия

Самостоятельная дистанционная ЛТ

1. первичный очаг и клинически определяемые метастазы (узлы ≥ 1 см или с центральным некрозом): СОД 66–70 Гр;
2. профилактическое облучение шеи (уровни Ib–III) на стороне поражения — при низкодифференцированных и местно-распространённых (T3–4) опухолях, кроме ацинарноклеточного и аденокистозного рака;
3. облучение противоположной половины шеи (I–III уровни) до СОД 50 Гр — при метастазах в нескольких узлах и при опухолях поднижнечелюстной железы;
4. режим: РОД 2 Гр, 5 раз в неделю, 6–7 недель.

Послеоперационная ЛТ

1. показания: низкодифференцированная опухоль, положительные или близкие края, перineвральная инвазия, сосудистая эмболия, метастазы в узлах, T3–4a, аденокистозный рак, нарушение целостности узла при удалении;
2. ложе опухоли (при перineвральной инвазии — с каналом лицевого нерва до коленчатого ганглия, язычным и подъязычным нервами до основания черепа): СОД 50–66 Гр;
3. регионарные зоны I–III при всех опухолях поднижнечелюстной железы, кроме ацинарноклеточной и аденокистозной в стадии T1: СОД 50 Гр;
4. начало — **через 6–8 недель** после операции; РОД 2 Гр, 5 раз в неделю, 5–6,5 недели.

4.4 Лекарственная терапия

Одновременная ХЛТ: ЛТ на первичный очаг (70 Гр) и лимфатические узлы (50 Гр) по 2 Гр в сутки 5 дней в неделю 7 недель; цисплатин 100 мг/м^2 на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни ЛТ (суммарно 300 мг/м^2).

При отдалённых метастазах и состоянии ECOG 0–3 проводится лекарственная терапия, выжидательная тактика при медленной прогрессии, селективная метастазэктомия или антиандрогенная терапия при гиперэкспрессии рецепторов к андрогенам.

Предпочтительные режимы ХТ при рецидивных неоперабельных опухолях и инкурабельных метастазах

1. #паклитаксел 175 мг/м^2 в 1-й день + карбоплатин AUC 5–6, каждые 3 недели;
2. доксорубицин 50 мг/м^2 в 1-й день + #блеомицин 30 мг в 1–5-й дни + цисплатин 20 мг/м^2 в 1–5-й дни, каждые 3 недели;
3. доксорубицин 60 мг/м^2 в 1-й день + #блеомицин 10 мг в 1–5-й дни + #винкристин 1,4 мг/м^2 в 1-й и 8-й дни, каждые 3 недели;
4. цисплатин 50 мг/м^2 + доксорубицин 50 мг/м^2 + #циклофосфамид 500 мг/м^2 в 1-й день, каждые 4 недели.

Дополнительные режимы

1. доксорубицин 60 мг/м^2 + цисплатин 40 мг/м^2 в 1-й день, каждые 3 недели;
2. доксорубицин 30 мг/м^2 + #цисплатин 50 мг/м^2 в 1-й и 8-й дни, каждые 3 недели;
3. #паклитаксел 60–80 мг/м^2 + #карбоплатин AUC 2 еженедельно;
4. #гемцитабин 1000 мг/м^2 в 1-й и 8-й дни + цисплатин 70 мг/м^2 во 2-й день, каждые 3 недели;
5. цисплатин 80 мг/м^2 в 1-й день + #винорелбин 25 мг/м^2 в 1-й и 8-й дни, каждые 3 недели.

Кумулятивная доза доксорубицина не должна превышать **450–500 мг/м^2**.

Таргетная и гормональная терапия при рефрактерности к стандартной ХТ

1. **мутация ERBB2 (HER2)** — #трастузумаб 2 мг/кг еженедельно (нагрузочная 4 мг/кг) в монотерапии или 6 мг/кг раз в 3 недели (нагрузочная 8 мг/кг) в комбинации
2. **рецепторы к андрогенам, ECOG 0–3** — #бикалутамид 150 мг 1 раз в сутки; для максимальной андрогенной блокады — #гозерелин 3,6 мг раз в 28 дней (или 10,8 мг раз в 84 дня) + #бикалутамид 50 мг в сутки
3. **мутация BRAF** — #дабрафениб 150 мг 2 раза в сутки + #траметиниб 2 мг 1 раз в сутки

Для поиска мишеней проводится комплексное геномное профилирование (NGS) ткани опухоли или жидкостной биопсии.

1. **MSI-H/dMMR или TMB ≥ 10 mut/Mb** — по решению врачебной комиссии #пембролизумаб 200 мг раз в 3 недели, не более 24 месяцев
2. **слияние гена NTRK** — ларотректиниб 100 мг 2 раза в сутки или энтректиниб 600 мг в сутки
3. **аденокистозный рак** — #ленватиниб 24 мг в сутки или #сорафениб 800 мг в сутки

Обезболивание проводится по клиническим рекомендациям «Хронический болевой синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи».

4.5 Медицинская реабилитация

Всем пациентам показана пререабилитация: физическая подготовка, психологическая и нутритивная поддержка, информирование. Она ускоряет восстановление и снижает частоту осложнений. Перед операцией полезна лечебная физкультура, перед комплексным лечением — профилактическая гимнастика и обучение глотанию.

Показания к нутритивной поддержке перед операцией (хотя бы одно)

1. непреднамеренное снижение массы тела **на 10% и более за 3 месяца**;
2. индекс массы тела **менее 18,5 кг/м²**;
3. ухудшение возможности приёма пищи за последнюю неделю;
4. калорийность питания **менее 1500 ккал в сутки**.

Предпочтительно пероральное питание (сиппинг); при невозможности — назогастральный зонд или гастростома, затем парентеральное питание. Калорийность — 25–30 ккал/кг, белок — 1,0–1,5 г/кг в сутки.

На I этапе: протоколы ускоренного восстановления после операции, ранняя мобилизация с 1–2-х суток, обезболивание в сочетании с физиотерапией и упражнениями для мышц лица и шеи, медицинский массаж.

До и после операции показана консультация логопеда при дисфагии; активную тренировку не проводят в раннем послеоперационном периоде, при первичном заживлении и свищах.

На II этапе: упражнения против тризма, раннее лечение лимфедемы — полная противоотёчная терапия, медицинский массаж, низкочастотная магнитотерапия.

На III этапе: упражнения для мышц лица и шеи, лечебная физкультура при дисфагии, стабильная масса тела и аэробная нагрузка 150 минут в неделю.

На фоне химио- и химиолучевой терапии рекомендованы аэробные упражнения и упражнения на сопротивление в сочетании с психологической поддержкой.

Низкоинтенсивную лазеротерапию применяют при полинейропатии и мукозите полости рта на фоне ХТ, а через 3 дня от начала ЛТ — для профилактики лучевого дерматита.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Периодичность обследований

1. первые 1–2 года: **каждые 3–6 месяцев**;
2. 3–5-й год: **1 раз в 6–12 месяцев**;
3. после 5 лет: **ежегодно** или при жалобах.

Объём обследования

1. анамнез и физикальное обследование;
2. УЗИ области первичной опухоли и лимфатических узлов шеи с двух сторон;
3. КТ или МРТ головы и шеи при признаках рецидива или недоступности зоны осмотру;
4. КТ органов грудной клетки **каждые 12 месяцев**;
5. тиреотропный гормон **каждые 6–12 месяцев** после облучения шеи;
6. ПЭТ-КТ по показаниям.

При высоком риске рецидива интервалы сокращают.

Наблюдение стоматолога до, во время и после лучевой терапии

1. оценка состояния полости рта и риска кариеса;
2. удаление «проблемных» зубов **не менее чем за 2 недели** до начала лечения;
3. профилактика остеорадионекроза и устранение источников инфекции.

После ЛТ для профилактики кариеса ежедневно длительно применяют гели с фторидом олова 0,4% или фторидом натрия 1,1%.

Цель визитов — контроль заболевания и отсроченных побочных эффектов: гипотиреоза после облучения шеи, нутритивного статуса, речевой и глотательной функции. Отказ от курения и алкоголя повышает выживаемость и эффективность лечения, снижает риск рецидива и вторых опухолей.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная или неотложная госпитализация

1. осложнения онкологического заболевания, требующие специализированной помощи;
2. осложнения лечения: хирургического, лучевого, лекарственного.

Плановая госпитализация

1. сложные интервенционные диагностические вмешательства с наблюдением в стационаре;
2. специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в круглосуточном или дневном стационаре.

Показания к выписке

1. завершение курса или этапа лечения при отсутствии осложнений, требующих стационарного лечения;
2. отказ пациента от лечения при отсутствии таких осложнений;
3. несоблюдение предписаний или распорядка, если это не угрожает жизни пациента и окружающих;
4. необходимость перевода в другую медицинскую организацию.

Консультация в центре амбулаторной онкологической помощи проводится **не позднее 5 рабочих дней** с даты направления; патолого-анатомическое исследование для верификации — **не более 15 рабочих дней**.

Тактику лечения определяет онкологический консилиум: онкологи и радиотерапевт, при необходимости — другие специалисты.

Факторы прогноза

1. размеры и распространённость первичной опухоли;
2. степень дифференцировки;
3. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
4. статус регионарных узлов (метастазы в узлах шеи вдвое снижают выживаемость) и экстранодальное распространение;
5. индекс пролиферации Ki-67;
6. статус краёв резекции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Злокачественные опухоли слюнных желёз»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 14.08.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	116_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи; Российское общество клинической онкологии; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность терапии #дабрафенибом и #траметинибом указана одновременно как «12 мес.» и «до прогрессирования или непереносимой токсичности».
- Перечень параметров патолого-анатомического заключения различается: в разделе 2.3 — 7 параметров, в критерии качества № 5 добавлена глубина инвазии опухоли.

Клинические рекомендации

Инородное тело в пищеварительном тракте

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**T18** — Инородное тело в пищеварительном тракте
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"; Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"; Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов" ; Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/710_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Инородным телом пищеварительного тракта называют любой объект, проглоченный, введённый в его просвет или образовавшийся в нём, который не может служить пищей.
- При поступлении показан осмотр оториноларинголога для исключения инородного тела полости рта и глотки и осмотр хирурга для выявления признаков перфорации и других осложнений.
- Диагноз устанавливается при обнаружении инородного тела при рентгенологическом или эндоскопическом исследовании либо во время операции.
- При батарейке, остроконечном предмете или полной обструкции в пищеводе эндоскопическое удаление выполняется экстренно: **лучше в течение 2 часов, не позднее 6**. Остальные инородные тела пищевода, в том числе магниты, удаляют срочно, **в течение 24 часов**.
- Дисковую батарейку у ребёнка, в том числе находящуюся в желудке, удаляют независимо от симптомов, размера и количества: **лучше в течение 12 часов, не позднее 24**.
- Наблюдение без извлечения допустимо, если инородное тело находится вне пищевода, не вызывает симптомов, тупое, инертное и небольшое (**до 2–2,5 см в диаметре или 5 см в длину**).
- Консервативное ведение при батарейках и магнитах противопоказано; эндоскопическое удаление контейнеров с наркотиками не рекомендуется.
- Пациентов госпитализируют в многопрофильный стационар с круглосуточной эндоскопической службой; при аспирации, перитоните, кишечной непроходимости — в отделение реанимации и интенсивной терапии.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Инородное тело пищеварительного тракта — объект органического, неорганического или искусственного происхождения, случайно или намеренно проглоченный, введённый в просвет пищеварительного тракта или образовавшийся в организме, который по составу и (или) расположению не может служить пищей.

Условно инородные тела — пища, желчные камни, паразиты, становящиеся инородным телом при определённых обстоятельствах: вклинение пищевого комка в зону сужения пищевода, миграция желчного камня в просвет кишки, конгломерат паразитов.

Инородные тела по воздействию на стенку

Вид	Определение
Инертные	без выраженного патологического воздействия на стенку: монеты, мелкие игрушки, клипсы, стеклянные и металлические шарики
Механически активные	механическое повреждение стенки: иголки, булавки, саморезы, проволока
Физически активные	выраженное физическое, компрессионное воздействие: магниты
Химически активные	химические и термические ожоги вплоть до перфорации: дисковые батарейки таблеточного типа
С комбинированным воздействием	механическое (обтурация, компрессия) и химическое воздействие: безоары, силикагелевые шарики

Признак Турнера — ощущение инородного тела в гортаноглотке или пищеводе даже после его прохождения в желудок.

2.2 Этиология

У детей инородные тела пищеварительного тракта встречаются чаще, чем у взрослых; пик заболеваемости приходится на возраст от 6 месяцев до 6 лет. Наиболее распространены у детей монеты: самостоятельно через пищевод они проходят у 30–60%.

Застрявшая в пищеводе дисковая батарейка является экстренной ситуацией, угрожающей жизни ребёнка: возможны трахеопищеводный и трахеоаортальный свищ, медиастинит, абсцесс шеи.

Взрослые проглатывают инородные тела случайно, а пациенты с психическими заболеваниями и отбывающие наказание — намеренно; «курьеры» проглатывают контейнеры с наркотиками. Отдельную группу составляют ятрогенные инородные тела (видеокапсулы, стенты, зубные протезы).

2.3 Классификация

1. по происхождению: истинные (проглоченные умышленно, случайно, незаметно; введённые через задний проход; оставленные при вмешательствах; попавшие при травме) и условно инородные тела (вклиненный пищевой комок; желчные камни, безоары, каловые камни; живые инородные тела);
2. по локализации: пищевод (68,4%), желудок (18,9%), тонкая кишка (7,1%), толстая кишка (3%), прямая кишка (2,6%).

1. по количеству: единичные, множественные;
2. по динамике: мигрирующие, свободнолежащие, фиксированные;
3. по величине: мелкие (**до 2–2,5 см в диаметре или до 5 см в длину**), средние (2,5–5 см или до 10 см), крупные (более 5 см или более 10 см);
4. по воздействию: инертные; потенциально агрессивные (контейнеры с наркотиками, хрупкие предметы); агрессивные, в том числе химически (батарейки), физически (магниты, ртуть), механически активные (остроконечные) и комбинированные (безоары, силикагель).

Рентгеноконтрастность инородных тел

Контрастность	Инородные тела
рентгеноконтрастные, хорошо видны на снимке	истинные рентгенопозитивные инородные тела непищевого происхождения, мясные кости
малоконтрастные и рентгенонегативные, как правило, не видны	пищевой комок, рыбьи и куриные кости, дерево, пластик, стекло, тонкие металлические предметы

Классификация Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии

Тип	Примеры
тупые	монета, пуговица, игрушка; батарейки, магниты
остроконечные	игла, зубочистка, кость, булавка, осколки стекла; фрагмент зубного протеза, лезвие
длинные	мягкие (струна, верёвка), твёрдые (зубная щётка, столовый прибор, отвёртка, ручка)
пищевые комки	с костями или без
другие	контейнеры с запрещёнными веществами

2.4 Клиническая картина

У детей зона глоточно-пищеводного перехода уже и длиннее, поэтому инородное тело чаще застревает в шейном отделе пищевода. Непищевые инородные тела составляют 75–90%, чаще возникает респираторный синдром.

Проявления у детей

1. кашель, одышка, свистящее дыхание, ложный круп;
2. гиперсаливация, слюнотечение, поперхивание, рвота;
3. дисфагия, одинофагия, отказ от еды, ощущение комка в горле.

У части детей симптомов нет до развития осложнений.

Инородное тело пищевода у взрослых (выраженная картина у 50–68%)

1. боль по ходу пищевода, в яремной ямке, затылке, спине, эпигастрии;
2. слюнотечение, невозможность проглотить твёрдую и жидкую пищу, дисфагия, срыгивание;
3. одышка; вынужденное положение при инородном теле в виде «якоря».

Вторичные проявления

1. лихорадка, обезвоживание, запах изо рта;
2. осиплость голоса;
3. инфильтрация мягких тканей шеи, подкожная эмфизема, пневмоторакс.

10% инородных тел пищевода бессимптомны; «мнимые» инородные тела — 10–15%.

Большинство инородных тел (80–90%) выходит самостоятельно; эндоскопическое удаление требуется в 10–20% случаев, хирургическое вмешательство — менее чем в 1%.

Клинические проявления инородных тел желудка и ДПК мало выражены: клинически проявляются только крупные, длинные и остроконечные предметы. При длительном нахождении инородного тела пролежень с последующей перфорацией стенки приводит к перитонеальным симптомам или забрюшинному инфильтрату.

Крупные инородные тела прямой кишки, особенно намеренно введённые у детей, вызывают тенезмы, боль в промежности и кровь в стуле. Отсутствие симптомов не служит поводом отказаться от обследования.

---

3. Диагностика

Диагноз подтверждается обнаружением инородного тела при рентгенологическом или эндоскопическом исследовании либо во время операции. На догоспитальном этапе и при поступлении диагноз основывается на анамнезе и данных осмотра.

3.1 Жалобы и анамнез

Тщательная оценка жалоб и детальный анамнез.

Необходимо выяснить

1. что проглочено (на снимке монета похожа на дисковую батарейку);
2. сколько прошло времени, когда последний раз ел и пил;
3. пытался ли пациент сам извлечь или «протолкнуть» инородное тело (сухой хлеб);
4. были ли попытки эндоскопического удаления;
5. были ли ранее такие эпизоды и установлен ли диагноз эозинофильного эзофагита, ГЭРБ, рубцовой стриктуры пищевода или ахалазии кардии;
6. у детей: имеются ли в анамнезе стенозы, ожоги пищевода или операции на нём.

У ребёнка с такой патологией дисфагия, слюнотечение, отказ от еды, поперхивание или апноэ при кормлении заставляют заподозрить инородное тело и являются показанием к эзофагоскопии.

Гиперсаливация и невозможность глотать жидкость свидетельствуют о полной непроходимости пищевода. Удушье, стридор и одышка могут быть следствием аспирации слюны или сдавления трахеи инородным телом.

3.2 Физикальное обследование при поступлении

Осмотр при поступлении

1. оториноларинголог: подтверждение или исключение инородного тела в полости рта и глотке;
2. хирург: признаки перфорации пищевода (подкожная эмфизема, отёк, инфильтрат шеи), осложнения со стороны желудка и кишечника;
3. аускультация лёгких: хрипы, признаки аспирации;
4. подозрение на инородное тело прямой кишки: пальцевое исследование.

Лихорадка и тахикардия настораживают в отношении осложнения. При длительно стоящем инородном теле пищевода и отсутствии торакального отделения пациента переводят в профильный стационар или вызывают специалиста.

3.3 Лабораторные исследования: анализы крови

При поступлении

1. общий анализ крови;
2. биохимический анализ крови: глюкоза, мочевина, креатинин, амилаза, билирубин, АЛТ, АСТ.

По показаниям

1. калий, натрий, тромбоциты;
2. АЧТВ, МНО, фибринолитическая активность;
3. группа крови и резус-фактор.

3.4 Рентгенография

При подозрении на рентгеноконтрастное инородное тело или если характер инородного тела неизвестен, выполняется неотложная рентгенография мягких тканей шеи, органов грудной клетки и брюшной полости.

Сначала выполняют снимок в прямой проекции; ложноотрицательные результаты достигают 47%, поэтому при отрицательном результате дополнительно выполняют боковую проекцию. Для шейного отдела пищевода выполняют снимок шеи в боковой и прямой проекции с приподнятой головой.

Детям с подозрением на проглатывание инородного тела, даже без симптомов, показана неотложная рентгенография шеи, грудной клетки и брюшной полости, по показаниям также таза, в 2 проекциях.

При застрявшем пищевом комке без костей и без признаков осложнений обзорная рентгенография, как правило, не рекомендуется: ложноотрицательные результаты достигают 87%.

3.5 Рентгеноскопия с контрастом

При подозрении на обтурацию или перфорацию пищевода, рентгенонегативном инородном теле, сомнениях в локализации выполняется рентгеноскопия глотки и пищевода с водорастворимым йодсодержащим контрастом. Исследование не должно задерживать эндоскопию.

Контраст дают малыми порциями. При нарушении глотания (инородное тело на уровне глоточно-пищеводного перехода, неврологические заболевания) йодсодержащий контраст не применяют из-за риска аспирации и отёка лёгких.

Применение бария сульфата не рекомендуется: он опасен аспирацией и затрудняет последующую эндоскопию.

3.6 Компьютерная томография

При клинической картине перфорации пищевода, флегмоны шеи, медиастинита и других осложнений выполняется КТ органов грудной и брюшной полости.

Рыбьи кости — частые инородные тела у взрослых, застревают в верхней части пищевода; чувствительность рентгенографии составляет 32%, КТ — 90–100%. У детей КТ выполняют при рентгенонегативных инородных телах. Свободный газ под диафрагмой при перфорации инородным телом — ненадёжный признак.

3.7 Эндоскопия

Перед эндоскопией анализируют клиническую картину и данные лучевых исследований, чтобы выбрать обезболивание, эндоскоп и инструменты.

Всем пациентам с подозрением на инородное тело верхних отделов пищеварительного тракта показана ЭГДС, в том числе при отрицательном результате рентгенографии; она же является первым этапом лечебного вмешательства. У детей инородное тело пищевода удаляют **менее чем через 24 часа**.

При подозрении на инородное тело прямой или сигмовидной кишки выполняется ректороманоскопия.

3.8 Дифференциальная диагностика

Сходная клиническая картина наблюдается при

1. кандидозном, рефлюкс- и эозинофильном эзофагите;
2. ахалазии кардии;
3. после инсульта, в дебюте рассеянного склероза, БАС, миастении;
4. опухоли пищевода;
5. истерии и других заболеваниях нервной системы.

При интенсивной боли за грудиной необходимо исключить острый коронарный синдром, при инородном теле желудка и кишки — заболевания с картиной острого живота.

---

4. Лечение

4.1 Сроки эндоскопии

Сроки эндоскопического вмешательства: экстренно — лучше в течение 2 часов, не позднее 6; срочно — в течение 24 часов; отсроченно — в течение 72 часов

Инородное тело	Пищевод	Желудок, тонкая кишка
батарейка	экстренно	срочно

Инородное тело	Пищевод	Желудок, тонкая кишка
магнит	срочно	срочно
остроконечное	экстренно	срочно
тупое, менее 2–2,5 см	срочно	отсроченно
тупое, 2–2,5–5 см	срочно	отсроченно (в тексте КР — в течение 24–48 часов)
большое, более 5–6 см	срочно	срочно
дисковая батарейка у ребёнка (текст КР, раздел 3)	экстренно	лучше в течение 12 часов, не позднее 24 часов
пищевой комок	экстренно (срочно — без симптомов и полной обструкции)	—

4.2 Консервативное ведение

Наблюдение без извлечения допустимо, если инородное тело находится вне пищевода, симптомов нет, оно тупое, инертное и небольшое (**до 2–2,5 см в диаметре или 5 см в длину**).

После пищевода большинство инородных тел проходит ЖКТ за **4–6 дней**, редко — до 4 недель; через привратник не проходят предметы более 2–2,5 см, через изгиб ДПК — длиннее 5–6 см. Без симптомов при инородном теле желудка меньше этих размеров возможно амбулаторное наблюдение: пациента предупреждают о симптомах перфорации и непроходимости.

При наблюдении за небольшим тупым рентгеноконтрастным инородным телом проводится периодический рентгенологический контроль, при отсутствии симптомов еженедельно. Если инородное тело не вышло из желудка **за 3–4 недели**, его удаляют эндоскопически.

При контейнерах с наркотиками без симптомов необходимы пристальное наблюдение в стационаре, лаваж кишечника и рентгенологический контроль; эндоскопически контейнеры не удаляют.

При безоаре желудка сначала применяют 5–10% раствор пищевой соды или напитки с ортофосфорной кислотой, которые размягчают растительные безоары; их приём продолжают между сеансами эндоскопии.

Консервативное ведение противопоказано

1. магниты и батарейки;
2. остроконечные инородные тела;
3. безоары, силикагелевые шарики;
4. любые длительно стоящие инородные тела пищевода.

Магнит удаляют, даже если на снимке он один.

4.3 Эндоскопическое лечение

Перед удалением анализируют анамнез, клиническую картину, данные лучевых исследований и эндоскопическую картину, чтобы выбрать обезболивание, эндоскоп и инструменты.

Экстренное удаление (**лучше в течение 2 часов, не позднее 6**) показано при полной обструкции пищевода, остроконечных предметах и батарейках в пищеводе. Остальные инородные тела пищевода, в том числе магниты, удаляют срочно (**в течение 24 часов**).

Частота перфорации остроконечными предметами достигает 35%. Дисковая батарейка быстро повреждает пищевод: электрический ожог, утечка щелочи, пролежень. Риск тяжёлых осложнений при инородном теле в пищеводе **более 24 часов** выше в 14,1 раза.

Из желудка и проксимальной части ДПК у детей с симптомами остроконечные, крупные инородные тела, магниты и батарейки удаляют экстренно (**в первые 2 часа**); у взрослых, а также у детей без симптомов (магниты) — срочно (**в течение 24 часов**).

Сроки удаления инородных тел желудка

1. дисковые батарейки у детей независимо от симптомов, размера и количества: **лучше в течение 12 часов, не позднее 24**; после 12 часов риск осложнений возрастает в 4,5 раза;
2. инородные тела более 2–2,5 см: **в течение 24–48 часов** (в таблице 3 КР — отсроченно, в течение 72 часов);
3. тупое небольшое инородное тело, не покинувшее желудок **за 3–4 недели** (желательно не более 1 недели): эндоскопическое извлечение.

Цилиндрическую батарейку у ребёнка в пищеводе удаляют экстренно (**лучше в течение 2 часов, не позднее 6**), в других отделах пищеварительного тракта — как можно быстрее.

Крупные инородные тела прямой кишки удаляют экстренно, особенно у детей: под наркозом после девульсии ануса, зажимами Кохера.

Удаление выполняют под общим обезболиванием; у детей только под наркозом с интубацией трахеи (или внутривенно с сохранением спонтанного дыхания, глубокая седация). У взрослых нетравмоопасные инородные тела удаляют под внутривенной анестезией или седацией, при невозможности под местной анестезией.

Методом выбора является гибкая видеоэндоскопия: успех более 95%, осложнения 0–5%. Ригидную эзофагоскопию применяют только при инородном теле в верхней трети пищевода, которое не удаётся извлечь гибким эндоскопом, при перфорации в операционной перед дренированием средостения или если гибкой эндоскопии нет.

При длительно стоящем инородном теле или после прежних безуспешных попыток извлечения его удаляют в операционной с инсуффляцией углекислого газа.

Раскрытую булавку, которую нельзя безопасно извлечь из-за расположения под углом, проводят в желудок, разворачивают и извлекают острым концом дистально. Длинный предмет захватывают за кончик.

При остроконечных инородных телах используют защитные устройства: дистальный колпачок, конус, тубус (для инородных тел дистальнее пищевода длиной 45–60 см).

Специальные инструменты по типу инородного тела: щипцы «зуб крысы», «зуб аллигатора», полипэктомические петли, корзины, сетчатые ловушки; биопсийные щипцы не рекомендуются.

Инструменты для извлечения у взрослых

Тип	Инструменты
тупые	щипцы-ретракторы, захваты, полипэктомические петли, корзинки, сетчатые ловушки
остроконечные	щипцы-ретракторы, петли, корзинки, сетчатые ловушки; прозрачный колпачок, латексный конус
длинные	полипэктомические петли, корзинки
пищевые комки	щипцы-ретракторы, захваты, петли, корзинки, сетчатые ловушки

Пищевой комок осторожно низводят в желудок; если это не удаётся, его извлекают целиком или по частям. При значительном сопротивлении проталкивание прекращают.

Эндоскопическое удаление контейнера с наркотиками не рекомендуется: разрыв ведёт к тяжёлой интоксикации и смерти.

При перфорации с флегмоной, медиастинитом, перитонитом изолированное эндоскопическое удаление противопоказано; оно возможно в операционной во время хирургического вмешательства.

Попытки извлечения прекращают при неостанавливаемом кровотечении и если дальнейшие попытки под наркозом увеличивают риск повреждения стенки (рыболовный крючок, проволока «егоза»).

После извлечения обязательно осматривают место фиксации и путь извлечения, оценивают повреждение стенки.

При «свежей» перфорации пищевода (**до 6 часов**) выполняют эндоскопическое клипирование с инсуффляцией углекислого газа. После ушивания целесообразно установить зонд в желудок для питания пациента.

После вклинения пищевого комка или задержки тупого инородного тела необходимо обследовать место задержки для выявления стриктуры, эозинофильного эзофагита, ахалазии, опухоли.

Патология пищевода выявляется более чем у 75% пациентов с вклинением пищевого комка; наиболее часты стриктуры (более 50%) и эозинофильный эзофагит (около 40%).

При подозрении на эозинофильный эзофагит выполняют биопсию из трёх третей пищевода. Стриктуры и кольца Шацкого можно расширить незамедлительно; при повреждении слизистой назначают ингибиторы протонного насоса, а дилатацию проводят через 2–4 недели.

4.4 После удаления

При значительном повреждении слизистой оболочки или глубоком ранении острым предметом выполняют рентгеноскопию с водорастворимым контрастом для исключения перфорации. Поздняя перфорация от пролежня возможна **на 2–5-е сутки**.

Если при травме стенки пищевода с отёком инородное тело не найдено, после противовоспалительной терапии повторяют рентгеноскопию с контрастом и эзофагоскопию, особенно если проглочена рыбья кость.

При выраженном отёке слизистой оболочки пищевода назначают щадящую диету на **3–4 дня** (жидкая, прохладная пища), ибупрофен или парацетамол.

Возможно также применение

1. масляных растворов бета-каротина;
2. облепихового масла;
3. гиалуроновой кислоты;
4. ИПП.

При воспалении, изъязвлениях, трещинах прямой кишки применяют НПВП в суппозиториях.

При значительном повреждении слизистой оболочки или ушитой перфорации назначают короткий курс антибиотиков (цефалоспорины, пенициллины). Даже без перфорации показано наблюдение в стационаре **2–3 дня**.

При операции по поводу перфорации, флегмоны, медиастинита, перитонита антибиотики широкого спектра вводят внутривенно как можно раньше, предпочтительно резервные (карбапенемы).

4.5 Медикаментозная терапия

Ибупрофен: детям до 6 лет по возрасту и массе тела, не более 30 мг/кг в сутки, интервал 6–8 часов

1. 3–6 месяцев: по 50 мг 3 раза в сутки, не более 150 мг в сутки;
2. 6–12 месяцев: по 50 мг 3–4 раза в сутки, не более 200 мг в сутки;
3. 1–3 года: по 100 мг 3 раза в сутки, не более 300 мг в сутки;
4. 4–6 лет: по 150 мг 3 раза в сутки, не более 450 мг в сутки;
5. взрослые и дети старше 6 лет: 200–400 мг 3–4 раза в сутки; не более 800 мг в сутки в 6–12 лет, 1000 мг в 12–17 лет, 1200 мг у взрослых.

Кетопрофен

1. старше 15 лет: внутримышечно 100 мг 1–2 раза в сутки; внутривенно 100–200 мг в 100–150 мл 0,9% раствора натрия хлорида, только в стационаре.

Парацетамол (противопоказан новорождённым)

1. масса тела более 50 кг: 1 г до 4 раз в сутки;
2. масса тела 10–50 кг: 15 мг/кг до 4 раз в сутки;
3. масса тела до 10 кг: 7,5 мг/кг до 4 раз в сутки.

Цефазолин, цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон: профилактика хирургической инфекции, дозы по инструкции

1. цефотаксим внутримышечно противопоказан детям **до 2,5 лет**;
2. цефтриаксон противопоказан недоношенным детям **до 41 недели**.

Оксациллин, амоксициллин + клавулановая кислота — дозы по инструкции; амоксициллин + клавулановая кислота противопоказан детям **до 2 лет**.

4.6 Хирургическое лечение

Показания к операции

1. инородное тело не удалось извлечь эндоскопически;
2. длительно стоящее в тонкой кишке, не извлекаемое при энтероскопии;
3. перфорация с флегмоной, медиастинитом, перитонитом;
4. тонкокишечная непроходимость;
5. кровотечение, не останавливаемое эндоскопически.

Операцию следует рассмотреть при опасном инородном теле, прошедшем за связку Трейца и не продвигающемся **3 дня**, если эндоскопическое извлечение невозможно. Истинной задержкой видеокапсулы считается её нахождение в тонкой кишке **более 2 недель**.

При контейнерах с наркотиками операция показана при подозрении на нарушение упаковки, отсутствии продвижения, кишечной непроходимости.

Объём операции определяется локализацией инородного тела и осложнениями. Если перфорация пищевода произошла **более 6 часов** назад, как правило, уже развился медиастинит.

Операция при перфорации пищевода

1. торакотомия, медиастинотомия;
2. удаление инородного тела, ушивание пищевода;
3. дренирование средостения и плевральной полости.

Гастростомия показана при технических трудностях ушивания перфорации пищевода, если уже развились гнойно-септические осложнения, в частности гнойный медиастинит.

При перфорации прямой кишки на всю толщину накладывают защитную колостому.

Диаметр пищевода по возрасту

Возраст	Диаметр пищевода
новорождённый	5–6 мм
6 месяцев	8–9 мм
1 год	12 мм
3–6 лет	13–15 мм
15 лет	18–19 мм
взрослый	20–22 мм

Эндоскопы для верхних отделов у детей

Масса ребёнка	Эндоскоп, мм	Канал, мм
новорождённые и младенцы до 10 кг	4,9–5,9	2,0–2,2
от 10 кг	7,8–9,2	2,2–2,8
более 25 кг — стандартные взрослые эндоскопы	9,2–9,9 и более	2,8–3,7

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Организация помощи и госпитализация

При подозрении на инородное тело пищевода в поликлинике выполняют обзорную рентгенограмму шейного отдела пищевода и направляют пациента в стационар с оториноларингологом и эндоскопической службой.

Не рекомендуется

1. вызывать рвоту и «проталкивать» инородное тело жёсткой пищей;
2. промывать пищевод и желудок на дому.

Все пациенты госпитализируются в многопрофильный стационар с круглосуточной эндоскопической службой; при аспирации, перитоните, кишечной непроходимости — в ОРИТ.

При тупом инертном инородном теле до 2–2,5 см без симптомов допустимо амбулаторное наблюдение. После успешного удаления без осложнений и без серьёзного повреждения стенки пациент может быть выписан незамедлительно.

Показания к госпитализации для наблюдения

1. технически сложное извлечение;
2. несколько предметов, остроконечные, батарейки, магниты, предметы более 5–6 см;
3. обширное повреждение слизистой;
4. травма пищевода 3–5 степени;
5. травма стенки без найденного инородного тела; патология пищевода, имитировавшая инородное тело.

Если острые предметы не извлечены, рентгенографию выполняют ежедневно, при батарейках дистальнее ДПК — каждые 3–4 дня.

При травме стенки пищевода пациента выписывают только после контрольной прицельной рентгенографии органов грудной клетки и эзофагоскопии.

Травмы пищевода (видоизменённая классификация Bassett, 1980)

Степень	Эндоскопическая картина
1	отёк и гиперемия слизистой, обилие слизи (катаральный эзофагит)
2	одиночные царапины, повреждены только верхние слои слизистой
3	значительный отёк, мелкие подслизистые кровоизлияния, скудное кровотечение — повреждена вся толща слизистой
4	слизистая разрушена на значительном протяжении, большие подслизистые гематомы, фибрин, контактная кровоточивость
5	глубокие слепые ранения со слизистой на подслизистый слой, отслойка слизистой 1–2 см, пролежень — повреждён внутренний мышечный слой
6	перфорация, глубокое непроникающее ранение с обильным кровотечением

5.2 Реабилитация и профилактика

После осложнений и операций реабилитацию проводят с учётом осложнения и вида операции; после самостоятельного отхождения или неосложнённого эндоскопического удаления специальная реабилитация, как правило, не нужна.

Родителям следует разъяснять недопустимость оставлять детей без присмотра.

При трихобезоаре необходимо наблюдение психиатра и (или) невролога, ЭГДС **каждые 6–12 месяцев в течение 2–3 лет**.

Необходимо лечить заболевание пищевода, ставшее причиной вклинения пищевого комка (стриктуру, эозинофильный эзофагит, опухоль).

Исход во многом определяется состоянием пищевода (опухоли, ахалазия, дивертикулы, ожоговые стриктуры, эзофагит, врождённая патология); тактика выбирается индивидуально.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Инородное тело в пищеварительном тракте»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 17.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	`710_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация детских хирургов; Российское общество хирургов; Российское общество рентгенологов и радиологов; Эндоскопическое общество «РЭндО»
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки удаления тупых инородных тел желудка 2–2,5–5 см различаются: в таблице 3 (приложение А3) — «отсроченно», то есть в течение 72 часов, в тексте раздела 3 — «в течение 24-48 часов от поступления». На странице приведены оба срока.

Клинические рекомендации

Кисты челюстно-лицевой области и шеи

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K04.8** — Корневая киста **K09** — Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках **K11.6** — Мукоцеле слюнной железы **L72.0** — Эпидермальная киста **Q18.0** — Пазуха, фистула и киста жаберной щели **Q18.1** — Преаурикулярная пазуха и киста **Q18.2** — Другие пороки развития жаберной щели **Q18.8** — Другие уточненные пороки развития лица и шеи
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.07.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/931_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Киста представляет собой полость с оболочкой из соединительнотканного слоя и эпителиальной выстилки, заполненную жидким или полужидким содержимым. Киста растёт за счёт давления содержимого: кость рассасывается, челюсть деформируется.
- Консультация оториноларинголога показана при кисте верхней челюсти, растущей в полость носа или верхнечелюстную пазуху, и при кисте шеи со свищом в глотку или к корню языка. При кисте мягких тканей шеи осмотр оториноларинголога необходим для исключения ларингоцеле.
- Диагноз устанавливается при выявлении кистозной полости в кости или мягких тканях по данным осмотра и лучевых исследований. Окончательный диагноз устанавливается по данным гистологического исследования.
- Лечение хирургическое: оболочку кисты удаляют в пределах здоровых тканей.
- Лечение небольшой кисты (**менее 3 зубов**) проводится амбулаторно. Показания к госпитализации:
  1. киста **более 3 зубов**;
  2. небольшая киста при тяжёлой сопутствующей патологии;
  3. нагноение кисты: экстренная госпитализация.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Киста является опухолевидным образованием: это полость, оболочка которой состоит из наружного соединительнотканного слоя и внутреннего, выстланного преимущественно многослойным плоским эпителием. Содержимым кисты являются серозная жидкость, гной, коллоиды и кристаллы холестерина.

Продукты эпителиальной выстилки и воспаление повышают давление в полости кисты; кислая среда от гипоксии активирует остеокласты, лизис кости преобладает над её образованием, поэтому киста растёт и челюсть деформируется.

2.2 Классификация кист челюстей

Клинико-морфологическая классификация (1975)

1. **Эпителиальные одонтогенные**: первичная (примордиальная кератокиста), киста прорезывания, парадентальная (периодонтальная), десневая, зубосодержащая, фолликулярная, корневая (радикулярная)
2. **Эпителиальные неодонтогенные**: киста резцового канала (носонёбного протока), глобуломаксиллярная (фиссуральная), носогубная (носоальвеолярная, преддверия полости рта), холестеатома
3. **Неэпителиальные**: костные кисты: аневризматическая, травматическая, геморрагическая

Клиническая классификация А. К. Иорданишвили (2000)

1. околозубные: околокорневые, резидуальные, околокоронковые (фолликулярные, кисты прорезывания), ретромолярные (парадентальные);
2. первичная киста (кератокиста);
3. киста носонёбного канала;
4. холестеатомы челюстей;
5. травматические;
6. аневризмальная костная киста;
7. шаровидно-верхнечелюстная киста;
8. носогубная (носоальвеолярная, внекостная).

2.3 Классификация кист мягких тканей

Врождённые

1. аномалии эмбриогенеза: срединные и боковые кисты шеи, кисты околоушной области и корня языка, кисты подъязычной слюнной железы;
2. пороки развития эктодермы: дермоидные и эпидермоидные кисты.

Приобретённые

1. ретенционные кисты сальных желёз (атеромы);
2. травматические;
3. кисты слюнных желёз.

Кисты жаберной щели по Bailey (1929) в модификации Proctor (1955)

Тип	Расположение боковой кисты шеи
I	поверхностно, вдоль передней поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы, под подкожной мышцей шеи; не соприкасается с влагалищем сосудисто-нервного пучка
II	самый частый: кпереди от грудино-ключично-сосцевидной мышцы и кзади от поднижнечелюстной железы, прилежит латерально к влагалищу сосудисто-нервного пучка
III	между внутренней и наружной сонными артериями, латеральнее боковой стенки глотки
IV	глубже влагалища сосудисто-нервного пучка, в окологлоточном пространстве; открывается в глотку, может распространяться к основанию черепа

2.4 Происхождение кист шеи и околоушной области

Кисты шеи и околоушной области

Киста	Происхождение
Срединная киста шеи	незаращение щитоязычного протока; связана с подъязычной костью и слепым отверстием корня языка, в стенке бывает ткань щитовидной железы
Боковая киста шеи	второй глоточный карман между наружной и внутренней сонными артериями, внутреннее устье расположено в области нёбной миндалины; лежит на сосудисто-нервном пучке, чаще на уровне бифуркации общей сонной артерии
Киста околоушной области	порок развития первой жаберной щели; латеральнее ствола лицевого нерва, связана с наружным слуховым проходом на границе хрящевого и костного отделов
Киста корня языка	аномалия щитоязычного протока; большая киста перед надгортанником мешает есть и дышать, нагноившаяся похожа на абсцесс корня языка
Лимфоэпителиальная киста	из остатков эпителия в лимфоидной ткани; из второй жаберной дуги развивается шейная лимфоэпителиальная киста (киста жаберной щели)

2.5 Клиническая картина

Киста челюсти

1. вне обострения симптомы могут отсутствовать, иногда определяется свищ на коже или слизистой оболочке;
2. большая киста деформирует челюсть: асимметрия лица, выбухание в полости рта;
3. при пальпации определяется «пергаментный хруст» или флюктуация;
4. большая киста смещает прорезывающиеся зубы, может привести к перелому нижней челюсти.

При нагноении кисты отмечаются асимметрия лица за счёт отёка и гиперемия кожи; перкуссия «причинного» зуба, как правило, болезненна. При нагноении фолликулярной кисты у ретенированного восьмого зуба нижней челюсти бывает затруднено открывание рта.

Срединная киста располагается по средней линии шеи между слепым отверстием языка и перешейком щитовидной железы. Она растёт медленно, безболезненная, гладкая, упругоэластическая; **при глотании смещается только вверх** вслед за подъязычной костью. Кожа над ней не изменена.

Боковая киста располагается впереди кивательной мышцы на уровне угла нижней челюсти и выявляется чаще в юношеском возрасте; киста округлая, эластическая, смещаемая.

1. **Дермоидная киста**: под языком и в языке, под мышцами дна полости рта, у корня носа, у углов орбиты, в надбровной области; мягкая, с кожей не спаяна
2. **Киста больших слюнных желёз**: безболезненная мягкоэластическая припухлость в околоушно-жевательной или поднижнечелюстной области; из протока выделяется неизменённая слюна
3. **Ранула**: округлое синюшно-прозрачное безболезненное образование подъязычной области; может опорожняться в рот и наполняться снова
4. **Киста малой слюнной железы**: округлое полупрозрачное, иногда голубоватое образование над слизистой оболочкой, подвижное, безболезненное

При нагноении кисты мягких тканей могут быть затруднены глотание, дыхание, движения языка, болезненны повороты головы; возможен свищ с отделяемым.

3. Диагностика

Диагноз кисты устанавливается при выявлении кистозной полости в кости или мягких тканях при осмотре и инструментальном обследовании и после исключения сходной патологии.

3.1 Жалобы и анамнез

Жалобы при кисте челюсти

1. вздутие альвеолярного отростка, асимметрию лица;
2. боль, отёк, припухлость тканей;
3. затруднение носового дыхания;
4. снижение чувствительности кожи нижней губы.

В начале киста бессимптомна.

В анамнезе выясняют

1. травму зуба;
2. степень разрушения зубов кариесом;
3. качество эндодонтического лечения;
4. ретенированные зубы.

Киста от центральных резцов верхней челюсти, растущая в нижний носовой ход, вызывает постоянную заложенность носа, а сдавление носослёзного канала приводит к одностороннему слезотечению.

При нагноении кисты челюсти к тем же жалобам присоединяются повышение температуры тела и озноб. При нагноении кисты, врастающей в верхнечелюстную пазуху, возникают боль в верхней челюсти и одностороннее отделяемое из носа.

При срединной кисте шеи пациентов беспокоят боль при глотании, болезненность в области языка, ощущение инородного тела при глотании, припухлость в передней области шеи.

При боковой кисте шеи пациенты предъявляют жалобы на асимметрию шеи, припухлость (иногда болезненная) в верхней трети боковой области шеи, односторонняя боль при глотании.

При дермоидной кисте мягких тканей пациенты предъявляют жалобы на асимметрию лица и шеи, наличие образования, эстетический дефект, нарушение подвижности языка, глотания и речи.

Жалобы при нагноившейся кисте мягких тканей лица и шеи

1. боль;
2. асимметрию лица или шеи;
3. отёк, припухлость;
4. затруднение дыхания;
5. повышение температуры тела, озноб.

При воспалении срединной, боковой и дермоидной кисты возможна дисфагия с расстройством речи.

3.2 Физикальное обследование

Помимо общего осмотра, выполняются наружный осмотр лица и шеи, осмотр полости рта, поверхностная и глубокая пальпация регионарных лимфатических узлов.

При кисте челюсти определяется сглаженность или выбухание переходной складки преддверия рта или нёба, затем «пергаментный хруст» (симптом Рунге — Дюпюитрена), а при появлении «окна» в кости флюктуация.

Дермоидная киста дна полости рта: эластичная или тестоватая, гладкая, с чёткими границами; киста, прикреплённая к подъязычной кости, образует полушаровидное выпячивание в подподбородочной области. Дермоидные кисты околоушной области лежат глубоко, под стволом лицевого нерва или его ветвями.

3.3 Зондирование и перкуссия зубов

При кисте челюсти выполняются зондирование, перкуссия и оценка подвижности зубов.

3.4 Риноскопия

При кисте носонёбного канала или кисте верхней челюсти, растущей в полость носа, и затруднении носового дыхания показана риноскопия для определения объёма операции и исключения патологии полости носа.

Киста, растущая к нижней стенке грушевидного отверстия, при риноскопии определяется как выпячивание на дне полости носа («валик Гербера»).

3.5 Лучевые исследования

Рентгенография при кисте челюсти

1. прицельная внутриротовая контактная;
2. ортопантомография;
3. панорамная рентгенография нижней челюсти;
4. рентгенография придаточных пазух носа;
5. рентгенография нижней челюсти в прямой и боковой проекциях.

Прицельного внутриротового снимка достаточно при околокорневой кисте **не более 7–10 мм**. При кисте **более 11 мм**, у премоляров и моляров нижней челюсти и при наложении анатомических образований выполняются ортопантомография, панорамный снимок, рентгенография пазух.

Если прицельного снимка недостаточно, выполняются панорамная рентгенография нижней челюсти, конусно-лучевая томография или КТ челюстно-лицевой области для оценки размеров и топографии кисты, состояния слизистой оболочки и стенок верхнечелюстной пазухи и полости носа.

При большой кисте челюсти показана спиральная КТ околоносовых пазух или КТ челюстно-лицевой области.

При кисте мягких тканей лица и шеи выполняются УЗИ мягких тканей и цитологическое исследование материала тонкоигольной аспирационной биопсии для оценки содержимого, размеров и топографии.

Если УЗИ недостаточно информативно, применяют МРТ мягких тканей или КТ челюстно-лицевой области.

3.6 Осмотр оториноларинголога

При кисте мягких тканей лица и шеи необходим осмотр оториноларинголога для исключения ларингоцеле.

3.7 Патологоанатомическое исследование

Патологоанатомическое исследование операционного материала выполняется всем пациентам для исключения злокачественного образования. Окончательный диагноз устанавливается по данным планового гистологического исследования.

3.8 Дифференциальная диагностика

Кисты челюстей дифференцируют с амелобластомой, гемангиомой, миеломой, эозинофильной гранулёмой, центральной гигантоклеточной гранулёмой, гигантоклеточной опухолью, фиброзной дисплазией, мягкой одонтомой, хондромой, остеомой, кистой Стафне, саркомой, метастазами карциномы. Для дифференциальной диагностики применяют КТ, ангиографию, сцинтиграфию, цитологическое исследование пунктата, биопсию.

Кисты околоушной области дифференцируют с кистами и опухолями околоушной слюнной железы и боковыми кистами шеи с помощью МРТ и цитологического исследования пунктата.

Дифференциальная диагностика дермоидных и эпидермоидных кист

1. туберкулёз лимфатических узлов (при первичной форме лёгкие могут быть не поражены);
2. лимфо- и ретикулосаркома: быстрый рост, множественное поражение узлов;
3. опухоли кроветворной системы;
4. аденолимфома слюнных желёз: в пунктате клетки опухоли;
5. боковые и срединные кисты шеи: пунктат дермоидной кисты атеромоподобный, с холестерином;
6. абсцедирующий лимфаденит;
7. атерома: дермоидная киста с кожей не спаяна.

Дифференциальная диагностика боковых и срединных кист

1. хронический лимфаденит шеи;
2. дермоидные кисты;
3. опухоли слюнных желёз (сиалография, МРТ, КТ);
4. каротидная хемодектома (МР- или КТ-ангиография);
5. метастазы, бранхиогенный рак, лимфо- и ретикулосаркома, гемангиома, лимфангиома;
6. для боковых свищей: свищи после нагноения лимфатических узлов.

Атерому отличают от эпидермоидной кисты, липомы, фибромы, лимфаденита, фурункула, ретенционной кисты по точечной втянутости кожи над протоком железы и спаянности кожи с оболочкой кисты.

---

4. Лечение

Основным методом лечения является хирургический: оболочку кисты удаляют в пределах здоровых тканей.

4.1 Подготовка зубов

Зубам, вызвавшим развитие корневой кисты, показаны пломбирование корневых каналов и резекция верхушек корней.

Канал пломбируют до операции, до уровня резекции верхушки, **не менее чем на 2/3 длины**. Если корень визуализируется в кисте во время операции, выполняется резекция верхушки корня уже запломбированного зуба.

Зубам, прилежащим к кисте и не реагирующим на ток при электроодонтометрии, показано пломбирование корневых каналов.

Электроодонтометрия, мкА

1. **2–8**: интактный зуб;
2. **9–14**: кариес;
3. **15–24**: глубокий кариес;
4. **25–44**: пульпит;
5. **45–80 или нет реакции**: периодонтит.

4.2 Кисты челюстей

Перед операцией

1. подписанное согласие пациента;
2. отсутствие хронических заболеваний в стадии декомпенсации и тяжёлых органных дисфункций;
3. выбор метода анестезии, по показаниям консультация анестезиолога-реаниматолога.

При нагноившейся кисте челюсти показано вскрытие и дренирование (цистотомия).

Показания к операциям при кисте челюсти

Операция	Объём операции	Показания
Цистэктомия	полное удаление оболочки кисты; дефект можно заместить остеопластическими материалами	оболочку можно удалить без опасности повредить соседние зубы, сосудисто-нервные пучки, стенки верхнечелюстной пазухи и полости носа
Цистостомия	создание соустья между полостью кисты и полостью рта	1. в полость кисты проецируются **3 интактных зуба и более**, на рентгенограмме у их корней не определяется периодонтальная щель; 2. большая киста верхней челюсти с разрушением костного дна полости носа и нёбной пластинки; 3. обширная киста нижней челюсти с истончением основания **менее 0,5 см**; 4. опасность повредить нижнечелюстной сосудисто-нервный пучок; 5. врастание кисты в верхнечелюстную пазуху или полость носа.
Марсупиализация	двухэтапная операция: сначала цистостомия, затем удаление остатков оболочки и свищевого хода	метод выбора для снижения травматичности и риска осложнений
Цисториносинусостомия	удаление оболочки кисты с радикальной операцией на верхнечелюстной пазухе и сообщением с нижним носовым ходом; при эндоскопической операции расширяют естественное соустье	киста челюсти проникает в верхнечелюстную пазуху: 1. интрасинусальная киста оттесняет дно пазухи вверх **на 1/3 высоты и более** (средняя и большая); 2. малая интрасинусальная киста с резким истончением костной перемычки: высок риск перфорации дна пазухи.

Методика костной пластики по величине дефекта

1. **1/4**: НКР с коллагеновой мембраной, одномоментная имплантация;
2. **2/4**: НКР с коллагеновой мембраной, нерезорбируемой мембраной;
3. **3/4**: НКР с нерезорбируемой мембраной, титановой сеткой;
4. **4/4**: НКР с нерезорбируемой мембраной, титановой сеткой, костные блоки (инлэй, онлэй), дистанционный остеогенез, «Graftless solutions».

НКР: направленная костная регенерация. Классификация остеопластических материалов приведена в разделе 3.2 PDF КР.

После декомпрессии кость восстанавливается аппозиционным ростом; полость промывают через трубку. Второй этап выполняется в среднем **через 0,5–1,5 года**.

Зуб удаляют, если его невозможно вылечить эндодонтически или ретроградно запломбировать.

При органосохраняющих операциях подлежат удалению «причинные» зубы

1. все временные зубы;
2. постоянные зубы, ставшие причиной кисты, если нельзя резецировать верхушки корней;
3. постоянные зубы, корни которых выступают в полость кисты **более чем на 1/2**.

Зуб также удаляют, если

1. подвижность зуба и атрофия альвеолярного отростка в области корней превышают II–III степень;
2. коронка разрушена настолько, что её невозможно восстановить;
3. корни значительно искривлены.

4.3 Кисты мягких тканей

При нагноившейся кисте мягких тканей лица и шеи показана цистотомия или пункция с эвакуацией гноя.

При срединной кисте шеи показана экстирпация кисты и свища **с резекцией тела подъязычной кости**. Лечение только хирургическое.

Под эндотрахеальным наркозом, горизонтальный разрез по кожной складке на уровне подъязычной кости; кисту выделяют тупо, не повреждая оболочку. Тело подъязычной кости резецируют клиновидно, **на 0,5 см** в обе стороны от свищевого хода.

При боковой кисте шеи показана цистэктомия. Лечение только хирургическое.

Под эндотрахеальным наркозом; разрез по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы (безопаснее) или по верхней шейной складке (косметичнее). Резиновый выпускник удаляют **на 2–3-и сутки**.

При кисте подъязычной слюнной железы показана цистэктомия.

Для снижения риска рецидива выполняется марсупиализация или цистэктомия с удалением подъязычной или поднижнечелюстной слюнной железы.

Марсупиализацию выполняют при большой рануле или повреждении оболочки: иссекают купол кисты, стенку подшивают к слизистой оболочке, в полость вводят турунду.

4.4 Малоинвазивные операции

Пациентам **старше 16 лет** с боковой кистой шеи без свищевого хода или дермоидной кистой боковой области шеи при наличии оборудования возможно видеоэндоскопическое или роботассистированное удаление.

Под эндотрахеальным наркозом; заушный доступ (RAHI, face-lift) или тоннельный доступ из разреза в волосистой части затылочной области. Вакуумный дренаж удаляют **на 1–2-е сутки**.

Пациентам **старше 16 лет** с кистой поднижнечелюстной слюнной железы выполняется видеоэндоскопическая или роботассистированная цистэктомия либо цистэктомия с удалением железы.

4.5 Профилактика раневой инфекции

Перед операцией проводится профилактика инфекционных осложнений в области хирургического вмешательства, по показаниям обезболивание и противоотёчная терапия. Антибиотикопрофилактику проводят по национальным рекомендациям «СКАТ», «НАСКИ».

Антибактериальный препарат системного действия вводят в разовой терапевтической дозе.

Повторная интраоперационная доза вводится, если операция длится дольше **двух периодов полувыведения** препарата, или при массивной кровопотере.

Препарат вводят однократно; при продлении профилактики его отменяют **не позднее 24 часов** после операции, даже если стоит дренаж.

При длительном сообщении раны с полостью рта профилактику можно продлить **до 48, максимум 72 часов**.

Рекомендуется разработка локальных протоколов антибиотикопрофилактики.

Антибиотикопрофилактика

Операция	Препараты выбора	Альтернатива	Категория
Нет риска сообщения раны с полостью рта («чистая рана»)	не рекомендуется	не рекомендуется	B
Риск сообщения раны с полостью рта или околоносовыми пазухами	цефазолин + метронидазол или амоксициллин + клавулановая кислота	клиндамицин	A

1. цефазолин + метронидазол: внутривенно детям **с 1 месяца**, дозы по инструкции; взрослым **2 г** цефазолина + **500 мг** метронидазола **за 60 минут** до операции;
2. клиндамицин: взрослым **600–900 мг** внутривенно перед операцией;
3. амоксициллин + клавулановая кислота: внутривенно взрослым и подросткам **старше 12 лет**, дозы по инструкции.

Цефазолин, метронидазол и клиндамицин в КР отмечены знаком #: применение вне инструкции.

При инфицированной ране (застарелая травма, предшествующая инфекция, гной, нежизнеспособные ткани) антибактериальную терапию начинают до операции.

После операции применяют терапевтические дозы с учётом веса, возраста, функции почек и печени, тяжести инфекции, риска резистентности и локальных микробиологических данных; при инфицированной ране необходимо микробиологическое исследование. Препаратами выбора являются комбинации пенициллинов с ингибиторами бета-лактамаз, другие бета-лактамы, ко-тримоксазол, линкозамиды, аминогликозиды, фторхинолоны, гликопептиды, производные имидазола, прочие.

4.6 Лекарственная терапия

Для обезболивания применяют анальгетики и НПВП с учётом противопоказаний и возрастных ограничений.

При нарушении целостности стенок верхнечелюстной пазухи или после операции в области носа применяют деконгестанты и другие назальные препараты для уменьшения отёка слизистой оболочки пазухи и соустья, улучшения дренажа и предупреждения воспаления.

По показаниям проводится противоотёчная терапия глюкокортикоидами.

Местно применяют антисептики и дезинфицирующие средства для профилактики инфекционных осложнений.

4.7 Диета

При кисте нижней челюсти показана челюстная диета для снижения риска патологического перелома и нагноения.

При кисте подъязычной, поднижнечелюстной или околоушной слюнной железы из рациона исключают слюногонную пищу.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Лечение небольшой кисты (**менее 3 зубов**) проводится амбулаторно.

Показания к госпитализации

1. небольшая киста при тяжёлой сопутствующей патологии;
2. киста **более 3 зубов**;
3. нагноение: экстренная госпитализация, в остальных случаях плановая.

Критерии выписки

1. острое воспаление купировано;
2. нет риска послеоперационного кровотечения.

5.2 Реабилитация

После операции проводится многоэтапная реабилитация до полного социального и физического восстановления.

Антибактериальная терапия в послеоперационном периоде назначается по показаниям. Осмотры и перевязки выполняются ежедневно, швы снимают **на 7–10-й день**, после чего пациента выписывают под амбулаторное наблюдение. Пребывание в стационаре до операции составляет **0–2** койко-дня, после операции **4–10**. После цистотомии и цистэктомии йодоформный тампон меняют **через 5–6 дней**, до 3–4 раз; к концу 3-й недели рана эпителизируется, полость пациент промывает сам. Полость уменьшается за счёт роста кости **за 1,5–2 года**.

При инфицировании сгустка необходимо создать отток экссудата между швами и промыть полость антисептиками; ежедневные промывания в течение **3–4 дней** нередко купируют воспаление. Если гнойный процесс сохраняется, края раны разводят, в полость вводят йодоформный тампон до гранулирования (**2–3 недели**).

5.3 Профилактика и диспансерное наблюдение

При первых симптомах кисты челюсти или мягких тканей показана консультация стоматолога-хирурга. Профилактика воспалительных одонтогенных кист заключается в своевременном лечении осложнённого кариеса и перикоронита.

Пломбирование зубов в зоне радикулярной кисты оптимально выполнять накануне или непосредственно перед операцией; перед операцией проводится санация полости рта. При парадентальных, фолликулярных и первичных кистах клинико-рентгенологический контроль после цистэктомии проводится **через 6 месяцев** и до восстановления кости; при фолликулярных и парадентальных кистах необходимо также наблюдение ортодонта. Наблюдение продолжают до полной нормализации клинико-рентгенологической картины.

При первых симптомах кисты мягких тканей показано УЗИ мягких тканей шеи.

При кисте верхней челюсти, растущей в полость носа или верхнечелюстную пазуху, показана консультация оториноларинголога.

При кисте мягких тканей шеи со свищевым ходом в области глотки или корня языка показана консультация оториноларинголога.

На исход влияют отрицательно

1. инфекционные осложнения;
2. нарушение ограничительного режима в раннем послеоперационном периоде;
3. нарушение диеты.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Кисты челюстно-лицевой области и шеи»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 28.07.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2028 года
Код в рубрикаторе	931_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии; Стоматологическая Ассоциация России
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для кисты челюсти в разделе 3.2 сразу три операции названы оптимальными: цистэктомия — «как наиболее оптимального», цистостомия — «как наиболее оптимального», марсупиализация — «как метод выбора». Выбор операции определяется показаниями из комментариев.
- Антибиотикопрофилактику рекомендовано отменять не позднее 24 часов после операции, а комментарий допускает продление до 48–72 часов.
- В таблице антибиотикопрофилактики категории рекомендаций A и B, а сами рекомендации раздела 3.5 — C, 5.
- Текст PDF — скан с ошибками распознавания; цитаты журнала сверки приведены по распознанному тексту, таблицы сверены по изображениям страниц 28 и 35.

Клинические рекомендации

Коклюш у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**A37** — Коклюш
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.01.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1023_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Коклюш — острая инфекция, вызываемая Bordetella pertussis, с длительным приступообразным судорожным (спазматическим) кашлем и поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.
- Коклюш подозревают при кашле **более 7 дней**: сначала сухой навязчивый, затем приступообразный судорожный, с репризами, рвотой или вязкой стекловидной мокротой; температура тела, как правило, нормальная, интоксикации нет.
- Подтверждение диагноза: ПЦР мазка со слизистой оболочки носоглотки однократно при кашле **от 7 до 28–35 дней**; при кашле **3 недели и более** — антитела к B. pertussis методом ИФА.
- Антибиотики (в первую очередь макролиды) показаны детям первого года жизни при обращении **в течение 6 недель** от начала болезни, остальным — **в течение 3 недель**; на длительность кашля они не влияют, но снижают заразность.
- Показания к переводу в ОРИТ: апноэ **более 15 секунд** у младенца или **более 10 секунд** у новорождённого, десатурация **SpO_2 менее 90%** при пароксизме, судороги, угнетение сознания.
- Осложнения, с которыми обращаются к оториноларингологу: носовые кровотечения на высоте кашля, кровотечения из заднеглоточного пространства и наружного слухового прохода, разрывы барабанной перепонки, вторичный отит.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Коклюш (Pertussis) — острое антропонозное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Bordetella (преимущественно Bordetella pertussis) и передающееся воздушно-капельным путём. Характеризуется длительным приступообразным судорожным (спазматическим) кашлем и поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Репризы — звучные судорожные вдохи, возникающие при прохождении воздуха через суженную вследствие ларингоспазма голосовую щель.

2.2 Этиология и патогенез

Возбудитель — Bordetella pertussis, грамотрицательная палочка, неустойчивая во внешней среде. Коклюшеподобное заболевание вызывают также B. parapertussis, редко B. bronchiseptica. Основное значение в патогенезе имеет коклюшный токсин с системным действием.

Длительный кашель связан с гиперреактивностью бронхов на фоне колонизации носоглотки B. pertussis; колонизация у реконвалесцентов и контактных может длиться более 3 и до 6 месяцев.

2.3 Эпидемиология

Индекс контагиозности у непривитых детей первого года жизни достигает 70–100%. Наибольшая заболеваемость и риск летальных осложнений — у детей до 1 года; источниками заражения младенцев чаще являются школьники и взрослые. После перенесённого коклюша иммунитет сохраняется 10–20 лет.

2.4 Классификация

1. **по форме**: типичная; атипичные — стёртая, бактерионосительство
2. **по тяжести**: лёгкая, среднетяжёлая, тяжёлая
3. **по течению**: гладкое; негладкое — с осложнениями, с наслоением вторичной инфекции, с обострением хронических заболеваний

2.5 Клиническая картина

Инкубационный период — **от 3 до 14 дней** (в среднем 7–8), реже до 21 дня.

Типичная форма

1. постепенное начало при нормальной температуре тела, без интоксикации;
2. сухой навязчивый кашель, нарастающий в динамике;
3. в разгаре — приступообразный судорожный кашель с репризами;
4. после приступа — рвота или отхождение вязкой стекловидной мокроты.

Степень тяжести коклюша

Тяжесть	Клиническая картина	Гемограмма
лёгкая	8–10 непродолжительных приступов в сутки, рвоты и кислородной недостаточности нет, состояние удовлетворительное	лейкоциты не более $10–15·10^9$/л, лимфоциты до 70%
среднетяжёлая	до 15–20 продолжительных приступов в сутки, рвота, периоральный цианоз при кашле; одутловатость лица, отёчность век, кровоизлияния в склеры; надрыв или язвочка уздечки языка	лейкоцитоз до $20–30·10^9$/л, лимфоцитоз до 80%
тяжёлая	25–30 и более приступов в сутки с рвотой и пароксизмами, постоянный цианоз, геморрагии на коже шеи и плечевого пояса; угрожающие жизни осложнения — апноэ, внутричерепные кровоизлияния, судороги	лейкоцитоз $40·10^9$/л и более, лимфоцитоз 85% и более

В приложении Г1 КР пороги частоты приступов другие: до 15, 16–25 и более 25 в сутки (таблица приложения — в «Подробнее»).

При определении тяжести основное значение имеют клинические критерии; гематологические изменения вспомогательны и оцениваются при моноинфекции.

Критерии степени тяжести по клиническим и гематологическим признакам

Признак	Лёгкая	Среднетяжёлая	Тяжёлая
цианоз лица при кашле	нет	цианоз носогубного треугольника	цианоз лица
длительность предсудорожного периода	10–14 дней	6–9 дней	3–5 дней
частота приступов кашля	до 15 в сутки, репризы редко	16–25 в сутки, репризы часто	более 25 в сутки, пароксизмы
лейкоцитоз	$10–15·10^9$/л	до $20–30·10^9$/л	более $40–50·10^9$/л
лимфоцитоз	до 70%	70–80%	более 80%

Специфические осложнения

1. пневмония, ателектаз, эмфизема средостения;
2. задержки дыхания до 30 секунд и остановки дыхания (апноэ) более 30 секунд;
3. коклюшная энцефалопатия (гипоксический отёк мозга, кровоизлияние в мозг);
4. кровотечения из носа, заднеглоточного пространства, бронхов, наружного слухового прохода; кровоизлияния в кожу, слизистые оболочки, склеры, сетчатку, головной мозг;
5. грыжи, выпадение слизистой оболочки прямой кишки;
6. разрывы барабанной перепонки и диафрагмы.

Неспецифические осложнения связаны с вторичной бактериальной флорой: пневмония, бронхит, бронхиолит, лимфаденит, отит.

Стратификация риска развития осложнений

Осложнение	Факторы высокого риска
Тяжёлое течение коклюша	1. возраст **младше 2 лет**; 2. недоношенность, бронхиальная астма, пороки развития бронхолёгочной системы, пороки и воспалительные заболевания сердца, врождённые герпесвирусные инфекции, поражения ЦНС; 3. гиперлейкоцитоз за счёт лимфоцитоза: лейкоциты **более $50 \cdot 10^9$/л**, лимфоцитоз **более 80%**; 4. отсутствие вакцинации.
Нарушения ритма дыхания (задержки и остановки дыхания)	1. возраст **младше 4 месяцев**; 2. недоношенность, морфофункциональная незрелость, пороки развития бронхолёгочной системы, гемодинамически значимые пороки и воспалительные заболевания сердца, врождённые герпесвирусные инфекции (в том числе цитомегаловирусная), поражения ЦНС; 3. снижение диуреза, нарастание пастозности лица, отёчности век, цианоз лица при кашле; 4. отсутствие вакцинации.
Тяжёлая коклюшная энцефалопатия с судорожным синдромом	1. возраст **младше 4 месяцев**; 2. недоношенность, пороки развития бронхолёгочной системы, гемодинамически значимые пороки и воспалительные заболевания сердца, врождённые герпесвирусные инфекции (в том числе цитомегаловирусная), поражения ЦНС; 3. напряжённость и выбухание большого родничка; 4. гиперлейкоцитоз за счёт лимфоцитоза: лейкоциты **более $50 \cdot 10^9$/л**, лимфоцитоз **более 80%**.
Вторичная бактериальная пневмония	1. появление фебрильной лихорадки и интоксикации; 2. локальные аускультативные и перкуторные изменения: мелкопузырчатые влажные хрипы, укорочение лёгочного звука; 3. нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, повышение СОЭ; 4. очаговые изменения в одном или нескольких сегментах на рентгенограмме.

Апноэ возникает преимущественно у детей первых месяцев жизни. Спазматическое апноэ развивается во время приступа кашля и длится от 30 секунд до 1 минуты; синкопальное не связано с кашлем: вялость, бледность, затем цианоз, остановка дыхания на 1–2 минуты при сохранённой сердечной деятельности.

Резидуальные изменения: хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, задержка психомоторного развития, судорожный синдром, речевые расстройства; редко у непривитых без лечения — слепота, глухота, парезы.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. эпидемиологических данных: контакт с больным коклюшем или кашляющими;
2. клинической картины: длительный, чаще приступообразный кашель;
3. прививочного статуса;
4. результатов лабораторной диагностики.

Для подтверждения диагноза достаточно положительного результата одного из лабораторных исследований.

3.2 Жалобы и анамнез

Целенаправленно выявляют кашель **более 7 дней** и уточняют его характер.

Что уточнить

1. в первые **7–14 дней** кашель сухой навязчивый, затем приступообразный судорожный; рвота после кашля присоединяется **на 2–3-й неделе**;
2. чем заканчивается приступ: рвотой, вязкой стекловидной мокротой;
3. репризы, цианоз лица во время приступа (признак тяжёлого течения);
4. задержки дыхания, судороги, нарушения сознания;
5. другие катаральные симптомы: ринорея, заложенность носа, боль или першение в горле, осиплость голоса, одышка.

Отсутствие типичных приступов не исключает атипичных (стёртых) форм у детей, привитых **в предшествующие 3–4 года**, подростков и взрослых. Отсутствие репризов коклюш не исключает.

Уточняют контакт с больным коклюшем или длительно (**более 3–4 недель**) кашляющим ребёнком или взрослым. При контакте с лабораторно подтверждённым случаем и коклюшеподобной картине можно диагностировать эпидемиологически связанный случай.

Уточняют температуру тела в начале болезни: в предсудорожном периоде она повышается редко, что помогает дифференциальной диагностике; лихорадка возможна при наслоении ОРВИ или осложнениях. Интоксикации при гладком течении нет.

Уточняют вакцинальный статус: вакцинация не исключает заболевания, но исключает тяжёлую форму.

3.3 Осмотр кожи и уздечки языка

Оценивают кожу: периоральный цианоз, отёчность лица и век, петехии на лице, кровоизлияния в склеры и кожу век. Цианоз, отёчный и геморрагический синдромы свидетельствуют о среднетяжёлом или тяжёлом течении; геморрагический синдром проявляется также носовыми кровотечениями на высоте кашля.

Осматривают уздечку языка: надрыв или язвочка характерны для коклюша, но их отсутствие коклюш не исключает.

3.4 Аускультация лёгких

При аускультации в периоде судорожного кашля выслушивают жёсткое дыхание и непостоянные грубые проводные хрипы, исчезающие после приступа. Постоянные хрипы, очаговая симптоматика и бронхообструктивный синдром для моноинфекции нехарактерны и указывают на осложнение или сочетанную инфекцию.

3.5 Общий анализ крови

Всем пациентам с подозрением на коклюш показан общий развёрнутый анализ крови: лейкоцитоз за счёт лимфоцитоза при нормальной СОЭ свидетельствует в пользу коклюша.

Отсутствие типичных изменений коклюш не исключает. Нейтрофилёз, сдвиг формулы влево, ускорение СОЭ указывают на осложнения или сочетанную инфекцию. При лейкоцитозе анализ повторяют до нормализации.

3.6 ПЦР мазка из носоглотки

Определение ДНК B. pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica в мазке со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР однократно — для подтверждения диагноза.

ПЦР применяется у пациентов, кашляющих **более 7, но не более 28–35 дней**, и у контактных работников детских учреждений; результат не зависит от вакцинации и антибактериальной терапии. Для контроля эффективности лечения ПЦР не используется: ДНК погибших микробов сохраняется **до 3–4 недель**.

Специфичность ПЦР 85–98%, чувствительность 45–65%.

3.7 Антитела к Bordetella pertussis методом ИФА

Пациентам, кашляющим **3 недели и более**, определяют антитела к B. pertussis методом ИФА: IgM, IgA в ранние сроки, IgG — в поздние. Метод предпочтителен у подростков и на сроке **более 4 недель**.

У привитых **в последние 5–7 лет** диагноз подтверждается четырёхкратным нарастанием титров IgG через 10–14 дней либо выявлением IgA и высоких титров IgG у привитых более 5 лет назад. Специфичность 89%, чувствительность 65%.

3.8 Посев слизи с задней стенки глотки

Двукратное культуральное исследование слизи с задней стенки глотки — при кашле **не более 14–21 дня**, до начала антибактериальной терапии, натощак или не ранее чем **через 2 часа** после еды.

Специфичность 100%, чувствительность 15% и менее: отрицательный результат коклюш не исключает; результат получают с задержкой.

3.9 Исследования на другие респираторные возбудители

Показания: негладкое течение или отсутствие эффекта терапии — лихорадка, нарастание катаральных симптомов, бронхообструкция.

Исследования

1. ПЦР мазков из носо- и ротоглотки на парагрипп, РС-вирус, метапневмовирус, риновирус, аденовирус, бокавирус;
2. ПЦР на Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae;
3. антитела к Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в крови.

Детям первого года жизни при тяжёлом и негладком течении определяют маркеры активной цитомегаловирусной инфекции (IgM, ДНК ЦМВ в крови, моче, слюне): она достоверно повышает риск тяжёлого течения и неблагоприятного исхода.

Признаки риска врождённой инфекции в анамнезе

1. негладкое течение беременности и родов;
2. недоношенность, низкая масса тела при рождении;
3. недостаточные прибавки массы тела в первые месяцы жизни;
4. затяжная желтуха новорождённых.

Нехарактерные для коклюша проявления

1. бронхообструктивный синдром;
2. умеренная гепатоспленомегалия;
3. повышение аминотрансфераз (АЛТ, АСТ);
4. признаки нефропатии: лейкоциты или эритроциты в моче;
5. энтероколит лёгкой степени (лейкоциты в кале) при отсутствии установленной кишечной инфекции.

3.10 Рентгенография лёгких

Показание: подозрение на пневмонию или ателектаз — лихорадка, интоксикация, очаговая симптоматика, одышка, тахипноэ, «стонущее» дыхание, учащение приступов.

3.11 Электрокардиография и эхокардиография

Показание: тяжёлое течение — ранняя диагностика кардиальных осложнений и лёгочной гипертензии; также фоновые заболевания и пороки сердца, тахикардия, аритмия.

3.12 Электроэнцефалография и нейросонография

Электроэнцефалография показана при тяжёлом негладком течении с декомпенсацией неврологической патологии, судорогами, признаками отёка мозга.

Нейросонография показана детям первого года жизни при появлении или нарастании неврологической симптоматики.

3.13 Бронхоскопия

Показание: обширные или не расправляющиеся **2 недели и более** ателектазы — оценка бронхиальной проходимости.

3.14 Пульсоксиметрия

Показание: тяжёлое течение, особенно с задержками дыхания, судорогами, пневмонией, бронхообструкцией — уточнение показаний к ИВЛ.

3.15 Консультации специалистов

Консультация офтальмолога показана при субконъюнктивальных кровоизлияниях.

Консультация невролога показана при тяжёлых формах с неврологической симптоматикой или сопутствующей неврологической патологией.

---

4. Лечение

Цели лечения

1. эрадикация возбудителя;
2. купирование приступов судорожного кашля;
3. предупреждение и лечение осложнений, в том числе апноэ и коклюшной энцефалопатии.

4.1 Этиотропная терапия

Всем пациентам с коклюшем назначают антибактериальные препараты системного действия: в первую очередь макролиды, при их непереносимости — пенициллины широкого спектра или цефалоспорины III поколения.

Препарат	Возрастная группа	Режим дозирования	Длительность
Азитромицин	**старше 6 месяцев**	10 мг/кг в сутки в 1 приём	5 дней
Эритромицин	в КР не указана	внутрь 10–15 мг/кг каждые 8 часов, не более 2 г в сутки	14 дней
#Кларитромицин	**старше 1 месяца**	внутрь 7,5 мг/кг 2 раза в сутки, не более 1 г в сутки	7–14 дней
#Пиперациллин + тазобактам	тяжёлое течение, в том числе **младше 2 месяцев**	в/в 40–50 мг/кг каждые 8 часов	1–2 недели
#Цефоперазон + сульбактам	тяжёлое течение	в/в 50–60 мг/кг каждые 12 часов	1–2 недели
Цефотаксим, цефтриаксон, ампициллин, амоксициллин	по инструкции	по инструкции	по инструкции

Антибиотики назначают детям первого года жизни, обратившимся **в течение 6 недель** от начала болезни, остальным — **в течение 3 недель**. Они уменьшают колонизацию и заразность, но не влияют на выраженность и длительность кашля.

Независимо от сроков антибиотики показаны при бронхолёгочных осложнениях вторичной флоры и хронических заболеваниях лёгких.

Азитромицин в суспензии 100 мг/5 мл: от 2,5 мл (50 мг) при массе 5 кг до 5 мл (100 мг) при 10 кг; 200 мг/5 мл: 2,5 мл при 10–14 кг, 5 мл при 15–24 кг, 7,5 мл при 25–34 кг, 10 мл при 35–44 кг, 12,5 мл (500 мг) при 45 кг и более.

Бессимптомным носителям в очагах антибиотики (предпочтительно макролиды) назначают только при тесном контакте с детьми групп риска тяжёлого течения и по эпидемическим показаниям.

Группы риска тяжёлого течения

1. младенцы **моложе 3 месяцев**;
2. непривитые или не получившие полный первичный курс;
3. недоношенные, с низкой массой тела при рождении или оценкой по Апгар менее 8;
4. тяжёлые врождённые пороки сердца;
5. лейкоцитоз более $20 \cdot 10^9$/л с лимфоцитозом более $10 \cdot 10^9$/л;
6. апноэ и цианоз в дебюте;
7. коинфекция или сопутствующая пневмония.

4.2 Патогенетическая и симптоматическая терапия

При спазматическом кашле применяют противокашлевые средства центрального действия: бутамират в каплях **с 2 месяцев**, в сиропе и таблетках — по инструкции.

При обильной вязкой трудноотделяемой мокроте — амброксол по инструкции. Одновременно противокашлевые и муколитические средства не назначают.

При среднетяжёлом, тяжёлом и осложнённом течении с дыхательными расстройствами, энцефалопатией или поражением нижних дыхательных путей — оксигенотерапия (кислородная палатка или маска, кислорода не более 40%).

Показания к кислороду

1. бледность, цианоз;
2. брадикардия;
3. сатурация **менее 93%**, в том числе во время пароксизма.

При остановке дыхания выполняют ритмичное надавливание на грудную клетку и искусственное дыхание ручным респиратором. При повторных задержках или остановке дыхания **более 30 секунд** ребёнка переводят в ОРИТ.

При признаках тяжёлого коклюша и угрожающих жизни осложнений показана консультация анестезиолога-реаниматолога для перевода в ОРИТ.

Признаки утяжеления и отёка мозга

1. судороги, апноэ;
2. выбухание и пульсация большого родничка;
3. любая степень угнетения сознания;
4. изменение ритма мочеиспусканий, нарастание отёков;
5. поражение нижних дыхательных путей, одышка, цианоз лица при кашле.

Показания к переводу в ОРИТ — в блоке «Показания к госпитализации».

Тяжёлый коклюш с отёком мозга и нарушениями ритма дыхания, разлитой цианоз лица при приступах у детей первых месяцев — системные глюкокортикоиды: #гидрокортизон 5–7 мг/кг **3 дня**, преднизолон или дексаметазон; курс **2–5 дней, не более 7–9**.

При судорогах на фоне коклюшной энцефалопатии применяют #диазепам внутривенно или внутримышечно.

1. разовая доза: 0,25 мг/кг, возможно 2 раза в сутки;
2. дети до 5 лет: не более 5 мг в сутки;
3. дети 6–12 лет: не более 20 мг в сутки;
4. дети старше 12 лет: не более 40 мг в сутки.

Другие противоэпилептические препараты применяют по назначению анестезиолога-реаниматолога или невролога.

При тяжёлом коклюше у детей раннего возраста для уменьшения гипоксии мозга назначают фенобарбитал (в КР указано «для детей **с 3 лет**»).

4.3 Иное лечение

При затруднённом откашливании проводят отсасывание слизи из верхних дыхательных путей электроотсосом, планово 2–3 раза в день или по показаниям, преимущественно у детей первого года.

При сочетанной ОРВИ назначают противовирусные препараты или иммуностимуляторы: интерферон альфа-2b, меглюмина акридонацетат (**с 4 лет**), антитела к гамма-интерферону аффинно очищенные (**старше 1 месяца**), комбинированные антитела к гамма-интерферону, гистамину и CD4 (**старше 6 месяцев**).

Специальных программ реабилитации нет. Реконвалесцентам тяжёлого негладкого коклюша (энцефалопатия, пневмония) и при коморбидных состояниях — реабилитация у профильных специалистов и санаторно-курортное лечение.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Лёгкое и среднетяжёлое течение без факторов риска лечится амбулаторно у педиатра или инфекциониста. Тяжёлое течение, среднетяжёлое с факторами риска, эпидемиологические показания — стационар с ОРИТ; угрожающие жизни осложнения — ОРИТ. В стационаре пациентов размещают в боксах.

Показания к переводу в ОРИТ

1. брадикардия или пароксизм с десатурацией **SpO_2 менее 90%**;
2. цианоз, вялость, выраженная бледность;
3. апноэ **более 15 секунд** у младенца или **более 10 секунд** у новорождённого;
4. апноэ любой продолжительности с десатурацией;
5. прогрессирующая дыхательная недостаточность;
6. угнетение сознания;
7. судороги;
8. подозрение на отёк головного мозга.

Критерий выписки из стационара — удовлетворительное состояние.

Критерии выздоровления

1. нет тяжёлых приступов кашля с репризами;
2. приступов кашля нет или их стало меньше;
3. гемограмма нормализовалась (лимфоцитоз может сохраняться долго);
4. при пневмонии — нормализация клинической, гематологической и рентгенологической картины.

5.2 Противоэпидемические мероприятия

Заразность наиболее высока в предсудорожном периоде и в начале периода судорожного кашля; **к 25-му дню** больной, как правило, незаразен. На фоне эффективной антибактериальной терапии ребёнок незаразен **через 5 дней** лечения или после окончания курса.

Без антибиотиков непривитый ребёнок в тесном контакте может заразиться **до 7-й недели** периода судорожного кашля.

Дети с коклюшем изолируются **на 25 суток** от начала заболевания. О случае сообщают по телефону **в течение 2 часов**, экстренное извещение направляют **в течение 12 часов**.

Мероприятия в очаге

1. карантин для контактных детей **до 7 лет** на **14 суток** от изоляции больного; дети старше 7 лет разобщению не подлежат;
2. на время карантина запрещены приём новых детей, не болевших коклюшем, и перевод из одной группы в другую;
3. ежедневное медицинское наблюдение за контактными детьми и взрослыми;
4. дезинфекция (текущая и заключительная) не проводится, достаточно проветривания и влажной уборки.

Контактные лица и бактерионосители

1. изоляция **не менее 14 дней** с момента прекращения общения или со дня выделения возбудителя, до 2 отрицательных результатов бактериологического исследования или однократного молекулярно-генетического исследования (ПЦР);
2. медицинское наблюдение за контактными **14 дней** с момента прекращения общения; при вторичных случаях в очаге **до 21-го дня** с момента изоляции последнего заболевшего;
3. заключительная дезинфекция не проводится.

Переболевшие допускаются в образовательные учреждения после **25-го дня** болезни.

Реконвалесцентов выписывают в коллектив при клиническом выздоровлении. От физкультуры освобождают **на 2 недели**, медицинский отвод от прививок — **1 месяц**.

Всем контактным детям, в том числе новорождённым, и взрослым после изоляции больного проводится постконтактная профилактика; препараты выбора — макролиды.

Профилактика показана независимо от возраста и вакцинального статуса при тесном контакте с больным манифестной формой в закрытом помещении **в течение 1 часа и более** или при контакте с его респираторными секретами.

Детям первого года жизни и непривитым детям **до 2 лет** с аллергией на макролиды вводят иммуноглобулин человека нормальный двукратно с интервалом 24 часа в разовой дозе 3,0 мл, как можно раньше после контакта.

5.3 Вакцинопрофилактика

По национальному календарю вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка проводится в **3 – 4,5 – 6 – 18 месяцев**. При нарушении сроков стремятся к полному курсу: 3 введения с интервалом не менее 1–1,5 месяца и ревакцинация через 12 месяцев; дополнительных доз при удлинении интервалов не требуется.

Перенесённый коклюш не создаёт длительной защиты и не является противопоказанием к вакцинации. В очаге активная иммунизация не проводится; частично привитым вакцинацию продолжают по календарю.

Для защиты ребёнка до начала вакцинации возможна однократная вакцинация беременной во II или III триместре, не позднее **15 дней до родов**, вакциной АаКдС.

Оптимальная стратегия — своевременный охват детей первых двух лет жизни и поэтапное внедрение возрастных ревакцинаций в 6–7 лет, 14 лет и взрослых каждые 10 лет.

Первоочередные группы для ревакцинации

1. дети и взрослые с хронической бронхолёгочной патологией, бронхиальной астмой;
2. иммунодефицитные состояния, ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания;
3. дети, первично привитые бесклеточными вакцинами;
4. дети из многодетных семей и закрытых учреждений;
5. сотрудники медицинских, образовательных и социальных учреждений;
6. взрослые в семьях с новорождёнными и непривитыми детьми до 1 года;
7. женщины, планирующие беременность.

Схемы вакцинации детей, не привитых своевременно

1. начало вакцинации и 1-я ревакцинация до 24 месяцев включительно: любые зарегистрированные вакцины по схеме 3+1, интервал между дозами 1,5–2 месяца, ревакцинация через 12 месяцев после 3-й дозы;
2. с 2 лет до 3 лет 11 месяцев 29 дней: АКДС-ВГВ, АаКДС, АаКДС-ИПВ//ХИБ;
3. с 4 до 5 лет 11 месяцев 29 дней: АаКДС или АаКДС-ИПВ//ХИБ по схеме 3+1; при нарушенном графике вакцинация продолжается вне зависимости от сроков предшествующей иммунизации вакцинами АаКДС-ИПВ//ХИБ, АаКДС, АакдС.

Продолжение вакцинации и ревакцинация

1. после 3 введений вакцины с коклюшным компонентом и 5 введений полиомиелитной вакцины: 1-я ревакцинация АаКДС или АакдС, интервал между 3-й дозой и ревакцинацией может быть сокращён до 6 месяцев;
2. 6–7 лет, не полностью привитые: АаКДС или АакдС;
3. старше 7 лет, ранее не привитые: двукратно АДС-М, 1-я ревакцинация через 6–9 месяцев вакциной АакдС;
4. одно введение вакцины с коклюшным компонентом: далее АДС-М или АакдС, 1-я ревакцинация через 6–12 месяцев вакциной АакдС;
5. 2 или 3 введения: однократная 1-я ревакцинация через 1 год после последнего введения (АДС-М или АакдС); возрастные ревакцинации в 14 лет и последующие — АДС-М или АакдС.

1. **АКДС, АКДС-ГепВ** — с 3 месяцев до 3 лет 11 месяцев 29 дней
2. **АаКДС** — с 2 месяцев до 7 лет
3. **АаКДС-ИПВ//ХИБ** — с 2 месяцев, при нарушении сроков — до 6 лет
4. **АаКДС-ИПВ-ВГВ//ХИБ** — с 2 месяцев до 2 лет
5. **АакдС** — с 4 лет и взрослым, разрешена беременным

5.4 Диспансерное наблюдение

Сроки наблюдения за реконвалесцентами коклюша

Специалисты	Длительность	Показания и сроки осмотров
пульмонолог, педиатр	6 месяцев	среднетяжёлые и тяжёлые формы с пневмонией, ателектазом, дыхательными расстройствами — через 2 и 6 месяцев после выписки
невролог, педиатр	1 год	тяжёлые формы с энцефалопатией, судорогами, внутричерепной гипертензией, кровоизлияниями — через 2, 6 и 12 месяцев после выписки

У реконвалесцентов тяжёлых форм с коклюшной энцефалопатией возможны задержка психомоторного и речевого развития; после внутримозговых кровоизлияний — снижение слуха и зрения, парезы.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Коклюш у детей»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.01.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2029 года
Код в рубрикаторе	`1023_1` · открыть текст КР ↗

Разработчик	Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Частота приступов кашля по степеням тяжести различается: в разделе 1.6 лёгкая — 8–10 в сутки, среднетяжёлая — до 15–20, тяжёлая — 25–30 и более; в приложении Г1 — до 15, 16–25 и более 25 соответственно.
- Фенобарбитал рекомендован «детям раннего возраста», но с пометкой «для детей с 3 лет» (раздел 3.1): ранний возраст — до 3 лет, указания противоречат друг другу.
- Суточный максимум #диазепама указан для детей до 5 лет и 6–12 лет; для детей от 5 до 6 лет предел не приведён (раздел 3.1).

Клинические рекомендации

Корь

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B05.9** — Корь без осложнений
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 06.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/563_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Корь — острое высококонтагиозное вирусное заболевание с воздушно-капельным путём передачи: лихорадка, интоксикация, поражение дыхательных путей и конъюнктив, пятнисто-папулёзная экзантема с переходом в пигментацию.
- Патогномоничный симптом катарального периода — пятна Бельского — Филатова — Коплика: беловато-серые точки с венчиком гиперемии на слизистой оболочке щёк напротив коренных зубов, появляются **за 1–2 дня до сыпи**. Сыпь появляется **на 4–5-й день** этапно: за ушами и на лице, затем туловище, затем конечности.
- Диагноз подтверждается ПЦР мазка из носоглотки (оптимально **в первые 3–5 суток**) и IgM к вирусу кори в ИФА.
- Частые осложнения — пневмония, острый средний отит, синусит. Антибактериальные препараты для профилактики бактериальной суперинфекции не применяются.
- Госпитализация — в мельцеровский бокс инфекционного стационара при тяжёлом или осложнённом течении и по эпидемиологическим показаниям; выписка — **не ранее 5-го дня** от начала высыпания.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Корь — острое высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём.

Характерные проявления

1. лихорадка и симптомы интоксикации;
2. поражение дыхательных путей и конъюнктив;
3. пятнисто-папулёзная экзантема с переходом в пигментацию.

2.2 Этиология, патогенез и эпидемиология

Возбудитель — РНК-содержащий вирус кори (Measles morbillivirus) семейства Paramyxoviridae. Вирус нестоек: во внешней среде сохраняется не более 30 минут, но распространяется с потоком воздуха на значительные расстояния. Входные ворота — слизистая оболочка верхних дыхательных путей и конъюнктива. Вирус обладает выраженным иммуносупрессивным действием (анергия), что ведёт к вторичному инфицированию и осложнениям.

Эпидемиология

1. индекс контагиозности 95–98%;
2. инкубационный период **9–21 день**;
3. больной заразен в последние дни инкубации, в продромальном периоде и **первые 4 суток** высыпания; **с 5-х суток** от появления сыпи незаразен;
4. заражение возможно и без непосредственного контакта, в том числе по вентиляционным каналам; после болезни — стойкий пожизненный иммунитет.

В 2022 г. в России зарегистрировано 102 случая кори (0,07 на 100 тыс.), 82,4% заболевших не привиты или прививочный анамнез неизвестен; в 2023 г. заболеваемость резко выросла.

2.3 Классификация

1. **по типу** — типичная; атипичная — митигированная, абортивная, стёртая, бессимптомная
2. **по тяжести** — лёгкая, средней тяжести, тяжёлая
3. **по течению** — гладкое; негладкое — с осложнениями, наслоением вторичной инфекции, обострением хронических заболеваний

2.4 Клиническая картина

Периоды типичной кори

1. **инкубационный** — **9–21 день**
2. **катаральный** — **3–4 дня**: температура 38–40 °С, ринит, фарингит, конъюнктивит, светобоязнь, интоксикация; нарастают катаральные явления, развивается ларинготрахеит; пятна Бельского — Филатова — Коплика **за 1–2 дня до сыпи**
3. **высыпания** — **с 4–5-го дня**, этапно: 1-е сутки — за ушами, переносица, лицо, шея, верх груди и плечи; 2-е — туловище; 3–4-е — дистальные отделы рук и ноги; сыпь пятнисто-папулёзная, сливная, ярко-красная
4. **пигментации** — **с 3–4-го дня** сыпи, этапно; длится **7–14 дней**, возможно отрубевидное шелушение

1. **митигированная** — после введения иммуноглобулинов, плазмы, крови в инкубационном периоде: периоды укорочены, симптомы стёрты
2. **абортивная** — типичное начало, **через 1–2 дня** симптомы исчезают, сыпь — на лице и туловище
3. **стёртая и бессимптомная** — слабые быстропроходящие симптомы или их отсутствие; выявляются, как правило, в очагах при обследовании контактных
4. **дети первого полугодия** — короткий слабый катаральный период, пятна Коплика могут отсутствовать, высыпание **до 2 дней**; быстро развиваются пневмония, отит, энцефалит
5. **привитые** — как правило, более лёгкое течение

Коревая анергия сохраняется **до 1 месяца** и служит фактором риска наслоения вирусно-бактериальных инфекций.

Осложнения возникают на любом этапе: первичные (коревые) и вторичные (бактериальные), ранние и поздние (в периоде пигментации).

1. пневмония — одно из наиболее частых осложнений;
2. острый средний отит, синусит;
3. кератоконъюнктивит, осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта;
4. коревой энцефалит (менингоэнцефалит) — **на 4–5-й день** после появления сыпи или позже, тяжёлое течение и высокий риск летального исхода.

Степени тяжести

Признак	Лёгкая	Средней тяжести	Тяжёлая
Лихорадка	**до 38,5 °С**, 1–5 дней	**более 38,5 °С**, 6–7 дней	**более 39,5 °С**, более 7 дней
Катаральный синдром	лёгкий	ярко выражен	ярко выражен более 7 дней
Экзантема	неяркая, необильная, бледная пигментация	обильная, яркая, склонная к слиянию	обильная, сливная, геморрагический синдром

Дифференциальный диагноз

1. краснуха, скарлатина;
2. аденовирусная, энтеровирусная, парвовирусная B19 и герпесвирусная HHV-6 инфекции;
3. инфекционный мононуклеоз;
4. токсикоаллергическая сыпь.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

1. **подозрительный случай** — острое заболевание с одним или несколькими типичными признаками кори
2. **вероятный случай** — клинические признаки и эпидемиологическая связь с подозрительным или подтверждённым случаем
3. **подтверждённый случай** — подозрительный или вероятный случай после лабораторного подтверждения

Окончательный диагноз устанавливается по клиническим данным при лабораторном подтверждении. В эпиданамнезе уточняют контакт с больным, пребывание в очаге, вакцинацию, введение иммуноглобулина.

3.2 Физикальное обследование

Оценивают

1. кожу и слизистые оболочки: сыпь, пятна Бельского — Филатова — Коплика, конъюнктивит;
2. температуру: при типичной форме 38–39 °C с первых дней, снижение на 2–3-й день, вторая волна **на 4–5-е сутки** вместе с сыпью;
3. лёгкие: в первые 3–4 суток возможны вирусные поражения, **с 5-х суток** — преимущественно бактериальные;
4. менингеальные и очаговые симптомы; сердце; живот (стоматит, энтерит, энтероколит).

3.3 Лабораторные исследования

Общий анализ крови — всем

1. **неосложнённая корь** — лейкопения, нейтропения, эозинопения, относительный лимфоцитоз, СОЭ не изменена
2. **бактериальные осложнения (пневмония, синусит)** — нарастают лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, СОЭ

1. **общий анализ мочи** — всем
2. **биохимический анализ крови** — при среднетяжёлом и тяжёлом течении; с 4-го по 8-й день возможен цитолиз (АЛТ, АСТ)
3. **СРБ и прокальцитонин** — при тяжёлом и осложнённом течении, подозрении на бактериальную инфекцию

3.4 Специфическая диагностика

ПЦР с обратной транскрипцией на РНК вируса кори в мазке из носоглотки — наиболее эффективный метод: РНК определяется ещё в инкубационном периоде, **за 3–5 дней** до сыпи.

1. больные: **3–5 суток** после манифестации или первый день госпитализации;
2. контактные: **через 5–7 дней** после контакта;
3. новорождённые от матерей, переболевших корью в конце беременности: только ПЦР (материнские антитела делают ИФА неинформативным).

IgM к вирусу кори в ИФА подтверждают диагноз; IgG определяют двукратно: 1-я сыворотка **на 4–5-й день** сыпи, 2-я — **не ранее чем через 10–14 дней**. Нарастание титра IgG **в 4 раза и более** в парных сыворотках служит основанием для диагноза.

3.5 Инструментальные исследования и консультации

1. **ЭКГ** — при подозрении на поражение сердца, при среднетяжёлой и тяжёлой кори, заболеваниях сердца
2. **рентгенография лёгких** — во всех случаях подозрения на пневмонию; при отрицательном результате — КТ (вирусная пневмония интерстициальная)

Консультации специалистов

1. **оториноларинголог** — при подозрении на отит или синусит
2. **невролог** — при тяжёлой кори и неврологических симптомах
3. **анестезиолог-реаниматолог** — при неотложных состояниях — решение о переводе в ОРИТ

---

4. Лечение

4.1 Консервативное лечение

Специфическое лечение кори не разработано. Постельный режим соблюдают весь период лихорадки и **2 суток** после нормализации температуры: его несоблюдение увеличивает риск осложнений. Объём жидкости — физиологическая потребность с учётом патологических потерь.

Этиопатогенетически применяют #интерферон альфа-2b; наиболее эффективен **в первые 3 суток** болезни.

1. дети до 7 лет: 150 000–500 000 МЕ;
2. дети 7–12 лет: 500 000–100 000 МЕ (так в тексте КР, см. «Неточности»);
3. старше 12 лет и взрослые: 1 000 000 МЕ;
4. кратность и длительность: 2 раза в сутки с интервалом 12 часов, 5–10 дней.

Для снижения температуры у детей применяют парацетамол (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофен (до 30 мг/кг в сутки) внутрь или ректально; есть форма парацетамола для внутривенного введения.

При среднетяжёлой и тяжёлой кори проводят инфузионную терапию растворами электролитов для дезинтоксикации и коррекции водно-электролитного баланса, исходя из потребности, потерь и дефицита жидкости.

Противомикробные препараты системного действия для предотвращения бактериальной суперинфекции не рекомендуются: при неосложнённой вирусной инфекции они не предотвращают суперинфекцию, а способствуют ей, подавляя нормальную флору.

Применяют местные средства (полоскания, тёплое питьё, ингаляции, таблетки и пастилки для рассасывания), физиотерапию и симптоматическую терапию; осложнения лечат по рекомендациям соответствующих нозологий.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Непривитым детям (не достигшим прививочного возраста, с противопоказаниями или отказом) иммуноглобулин человека нормальный вводят **не позднее 5-го календарного дня** с момента контакта.

Плановая вакцинация по национальному календарю

1. вакцинация: **в 12 месяцев**;
2. ревакцинация: **в 6 лет**.

Детей от серонегативных матерей прививают **в 8 месяцев** моновакциной, затем в 14–15 месяцев и в 6 лет.

Непривитые взрослые 18–35 лет прививаются двукратно с интервалом **не менее 3 месяцев**; однократно привитые более 3 месяцев назад получают одну дозу.

Охват вакцинацией и ревакцинацией детей в декретированных возрастах должен составлять не менее 95%, взрослых 18–35 лет и декретированных профессий 18–55 лет — не менее 90%.

Вакцинация по эпидемическим показаниям проводится **в первые 72 часа** с момента выявления больного, при расширении очага — **до 7 дней**.

Кому

1. контактным без ограничения возраста, не болевшим, не привитым и без сведений о прививках;
2. однократно привитым **старше 6 лет**.

Детям **до 8 месяцев** и лицам с противопоказаниями к живым вакцинам после контакта вводят иммуноглобулин.

5.2 Показания к госпитализации

Госпитализация в инфекционный стационар

1. тяжёлое и (или) осложнённое течение;
2. тяжёлые хронические заболевания;
3. независимо от тяжести: пребывание в организациях с круглосуточным пребыванием, общежитиях, неблагоприятных бытовых условиях; декретированные контингенты в семье.

Больных размещают в мельцеровских боксах; детей — в стационарах с отделением реанимации. В ОРИТ госпитализируют при тяжёлых и осложнённых формах с выраженной интоксикацией, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, церебральными нарушениями.

Критерии выписки

1. удовлетворительное состояние;
2. **не ранее 5-го дня** после начала высыпания.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Корь»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 06.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	563_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Доза #интерферона альфа-2b детям 7–12 лет указана как «500000–100000 МЕ» (нижняя граница больше верхней); по смыслу ряда доз — 500 000–1 000 000 МЕ.

- Жаропонижающие у детей названы «нестероидными противовоспалительными средствами… только на основе парацетамола или ибупрофена»; парацетамол к НПВП не относится.

Клинические рекомендации

Краниальные мононейропатии у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B02.2** — Опоясывающий лишай с другими осложнениями со стороны нервной системы **G44.0** — Синдром «гистаминовой» головной боли **G50.0** — Невралгия тройничного нерва **G50.1** — Атипичная лицевая боль **G50.8** — Другие поражения тройничного нерва **G50.9** — Поражение тройничного нерва неуточненное **G51.0** — Паралич Белла **G51.1** — Воспаление узла коленца **G51.2** — Синдром Россолимо-Мелькерссона **G51.3** — Клонический гемифациальный спазм **G51.4** — Лицевая миокимия **G51.8** — Другие поражения лицевого нерва **G51.9** — Поражение лицевого нерва неуточненное **G52.0** — Поражения обонятельного нерва **G52.1** — Поражения языкоглоточного нерва **G52.2** — Поражения блуждающего нерва **G52.3** — Поражения подъязычного нерва **G52.7** — Множественные поражения черепных нервов **G52.8** — Поражения других уточненных черепных нервов **G52.9** — Поражение черепного нерва неуточненное **G53.0** — Невралгия после опоясывающего лишая (B02.2+) **G90.0** — Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Всероссийское общество неврологов; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии; Некоммерческая организация «Ассоциация интервенционного лечения боли»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/895_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рекомендация охватывает поражения тройничного нерва (невралгия, атипичная лицевая боль, нейропатическая боль, автономные цефалгии), лицевого нерва (нейропатия, гемифациальный спазм, миокимия) и других черепных нервов.
- Паралич Белла является диагнозом исключения и развивается за 24–48 часов, максимум за 72 часа. Глюкокортикоиды назначают **как можно раньше, лучше в первые 72 часа**, при любой тяжести; при тяжёлой форме к ним добавляют противовирусные средства.
- При нейропатии лицевого нерва всем пациентам показан осмотр оториноларинголога с отоскопией, по показаниям — аудиометрия и тимпанометрия. Снижение слуха на стороне поражения для неё нехарактерно; при его наличии следует заподозрить объёмное образование.
- При «красных флагах» или сохранении симптомов **более 3 недель** выполняют МРТ головного мозга с контрастом.
- При тяжёлой нейропатии (V–VI степень) ЭНМГ выполняют **не ранее 8 суток**; снижение М-ответа на 90% и более служит основанием для направления к хирургу. Электростимуляция и форсированные упражнения не рекомендуются.
- Экстренная госпитализация при нейропатии лицевого нерва показана в первые **72 часа** для внутривенного введения #метилпреднизолона в высокой дозе, а также при других неврологических симптомах, нарастании тяжести с нарушением сознания, лихорадкой, менингеальными симптомами, декомпенсации артериального давления или сахарного диабета, при беременности.
- При тригеминальной невралгии препаратами первой линии являются карбамазепин и окскарбазепин.
- Невралгия языкоглоточного нерва проявляется приступами боли по типу удара тока в задней части языка, миндалине, глотке, у угла челюсти, в ухе; обследование включает МРТ, УЗИ шеи и видеоларингоскопию.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Тройничный нерв: определения

Тригеминальная невралгия — односторонние повторяющиеся кратковременные приступы боли по типу удара током, внезапно начинающиеся и прекращающиеся, провоцируемые безболевыми раздражителями, в зоне одной или нескольких ветвей тройничного нерва. Может сопровождаться постоянной фоновой болью умеренной интенсивности.

Атипичная лицевая боль и нейропатическая боль

Состояние	Определение
Персистирующая идиопатическая лицевая боль	постоянная боль в лице, ежедневно **более 2 часов в день** **более 3 месяцев**, без выраженных неврологических нарушений и предшествующей причины
Миофасциальная орофациальная боль, связанная с мышечным спазмом	боль от внезапного непроизвольного обратимого тонического сокращения жевательной мышцы; возможно острое нарушение прикуса
Синдром пылающего рта	жжение или дизестезия в полости рта ежедневно **более 2 часов в день** **более 3 месяцев** без признаков основного заболевания

Состояние	Определение
Тригеминальная нейропатическая боль	боль в зоне одной или нескольких ветвей тройничного нерва, вызванная другим заболеванием и указывающая на повреждение нерва

Тригеминальные автономные (вегетативные) цефалгии — первичные головные боли

1. **кластерная головная боль** — короткие односторонние атаки крайне сильной боли в области орбиты, подглазничной или височной области с вегетативными симптомами со стороны глаза и носа
2. **пароксизмальная гемикрания** — строго односторонняя боль в области орбиты, подглазничной или височной области по 2–30 минут, много раз в день, с вегетативными симптомами; купируется индометацином
3. **SUNCT** — короткие односторонние атаки боли в глазничной и окологлазничной области, всегда с инъекцией конъюнктивы и слезотечением
4. **SUNA** — то же, но инъекции конъюнктивы и слезотечения нет или есть только один из этих симптомов
5. **гемикрания континуа** — непрерывная односторонняя головная боль умеренной интенсивности с обострениями и вегетативными симптомами, абсолютный эффект индометацина

2.2 Лицевой нерв: определения

Нейропатия лицевого нерва — асимметрия лица из-за односторонней слабости мимических мышц (прозопарез — движения есть, прозоплегия — нет) с неполным закрытием глаза; симптомы по уровню поражения и поздние осложнения — ниже. Паралич Белла — идиопатическая форма.

Гемифациальный спазм — хронические пароксизмальные безболезненные непроизвольные односторонние тонические или клонические сокращения мышц лица, в том числе в покое и ночью.

Лицевая миокимия — спонтанные односторонние низкоамплитудные пульсирующие подёргивания одной мышцы лица (чаще нижней порции круговой мышцы глаза), от секунд до часов, реже до недель; заметнее пациенту, чем окружающим.

Краниальная невропатия — любое повреждение черепного нерва на любом уровне.

Уровни поражения лицевого нерва

1. мосто-мозжечковый угол;
2. внутренний слуховой проход;
3. костный канал до отхождения большого каменистого нерва;
4. костный канал до отхождения стремянного нерва;
5. выход через шилососцевидное отверстие;
6. околоушная железа;
7. отдельные ветви в мимических мышцах.

2.3 Причины

Причины тригеминальной невралгии по формам

1. **Классическая** обусловлена нейроваскулярным конфликтом: корешок сдавливает сосуд, чаще верхняя мозжечковая артерия
2. **Симптоматическая** возникает при опухоли, артериовенозной мальформации или демиелинизации при рассеянном склерозе
3. **Идиопатическая** — форма, при которой причина неизвестна

Паралич Белла является диагнозом исключения. Основными считают вирусную гипотезу (реактивация HSV-1, HSV-2, VZV на фоне стресса, переохлаждения, другой инфекции) и аутоиммунную. Заболевание связано с осенним сезоном, перепадами температуры и сахарным диабетом.

Формы и причины симптоматической нейропатии лицевого нерва

1. **Синдром Рамсея Ханта** — герпетическое поражение коленчатого узла с прозопарезом или прозоплегией на фоне боли и кожных высыпаний; у 50–85% пациентов протекает тяжелее паралича Белла и склонен к рецидивам
2. **Синдром Россолимо — Мелькерссона** — генетическое заболевание, при котором рецидивирует прозопарез в сочетании с отёком губ и складчатым языком
3. **Объёмные образования** (8–12% случаев) — шванномы лицевого нерва, опухоли мосто-мозжечкового угла и околоушной железы
4. **Другие частые причины** — осложнения хирургических, косметологических и стоматологических вмешательств, черепно-мозговая травма, неврологические заболевания, инфекции, метаболические нарушения; реже — радиохирургия вестибулярной шванномы
5. **Боррелиоз** — при нём изолированная нейропатия лицевого нерва наблюдается у 34–56% пациентов, что учитывают при дифференциальной диагностике

Причины гемифациального спазма по формам

1. **первичный** возникает при сдавлении корешка лицевого нерва сосудом, чаще передней нижней мозжечковой артерией
2. **вторичный** вызывают опухоль мосто-мозжечкового угла или околоушной железы, сосудистые аномалии, аномалия Киари, инфекции сосцевидного отростка и уха (средний отит, холестеатома), травма, поражение ствола мозга, перенесённая нейропатия лицевого нерва (постпаралитический гемиспазм)

Усиливают спазмы холод, яркий свет и стресс.

Синкинезии — непроизвольное сокращение одной группы мышц (или работа железы) при произвольном сокращении другой. Чаще всего окуло-скуловая и окуло-оральная (более 90%), оро-окулярная (59%), «крокодиловы слёзы» — слезотечение при жевании. Совокупность нескольких синкинезий называют постпаралитическим гемиспазмом.

Первичная миокимия возникает от физического или эмоционального перенапряжения, приёма кофеина и проходит самостоятельно. Вторичная развивается как побочный эффект препаратов (топирамат, габапентин), а также при дебюте рассеянного склероза, объёмного процесса ствола, вестибулярной шванномы, тиреотоксикоза.

Причины невралгии языкоглоточного нерва по формам

1. **классическая** обусловлена нейроваскулярным конфликтом
2. **вторичная** развивается при травме шеи, рассеянном склерозе, тонзиллярных или регионарных опухолях, опухоли мосто-мозжечкового угла, мальформации Арнольда — Киари
3. **идиопатическая** — форма, при которой причина не найдена

Поражения обонятельного нерва, нервов глазодвигательной и каудальной групп — проявления другого заболевания

1. нарушение мозгового кровообращения;
2. травма головы и шеи;
3. тромбоз венозных синусов;
4. воспалительные заболевания околоносовых пазух;
5. опухоли головы и шеи;
6. системные и метаболические заболевания;
7. миастения, боковой амиотрофический склероз;
8. сосудистые мальформации.

Тригеминальная нейропатическая боль развивается после травмы нерва, герпетической инфекции и по другим причинам; постгерпетическая невралгия обусловлена реактивацией Herpes zoster.

2.4 Классификация

Тригеминальная невралгия бывает классической, идиопатической и симптоматической. По классификации Burchiel к 1 типу относят невралгию только с типичными прострелами, ко 2 типу — невралгию, при которой к прострелам добавляется постоянная фоновая боль.

Атипичная лицевая боль (ICOP)

1. синдром пылающего рта: без соматосенсорных изменений, с соматосенсорными изменениями, возможный;
2. персистирующая идиопатическая лицевая боль: без соматосенсорных изменений, с ними, возможная;
3. миофасциальная орофациальная боль, связанная с мышечным спазмом.

«Возможный» — те же признаки, но **менее 3 месяцев**.

Тригеминальная нейропатическая боль (ICOP)

1. связанная с Herpes zoster;
2. постгерпетическая невралгия;
3. посттравматическая (и возможная посттравматическая);
4. связанная с другим нарушением (и возможная);
5. идиопатическая.

Тригеминальные автономные цефалгии

1. **эпизодическая кластерная головная боль** — не менее 2 периодов **более 7 дней** в году, ремиссия **более 3 месяцев** (около 80% пациентов)
2. **хроническая кластерная головная боль** — приступы **1 год** без ремиссий или с ремиссиями **менее 3 месяцев**
3. **пароксизмальная гемикрания** — эпизодическая — атаки от 7 дней до 1 года, ремиссия **от 1 месяца**; хроническая — **более 1 года** без ремиссий или с ремиссией менее 1 месяца
4. **SUNCT и SUNA** — эпизодические — атаки от 7 дней до 1 года, ремиссия **3 месяца и более**; хронические — более 1 года без ремиссии или с ремиссией менее 3 месяцев
5. **гемикрания континуа** — ремиттирующая (ремиссия не менее 1 дня без лечения) и неремиттирующая

Нейропатия лицевого нерва: идиопатическая (G51.0) и симптоматическая (G51.1, G51.2, G51.8, G51.9), поражение отдельных ветвей (G51.8). Гемифациальный спазм — первичный (G51.3) и вторичный. Лицевая миокимия — первичная (G51.4) и вторичная.

Языкоглоточный нерв (ICOP)

1. невралгия: классическая, идиопатическая, вторичная;
2. нейропатическая боль: с установленной причиной, идиопатическая.

2.5 Клиническая картина: тригеминальная невралгия

Диагноз — клинический, по характеру боли

1. приступ **от доли секунды до 2 минут**;
2. высокая интенсивность;
3. боль как электрический разряд, стреляющая, колющая, острая;
4. провокация безболевым воздействием на триггерные точки.

Провоцируют холодный воздух, чистка зубов, умывание, разговор, еда. Чувствительных нарушений нет, кроме симптоматической невралгии.

Персистирующая идиопатическая лицевая боль

1. постоянная тупая ноющая боль, без атак и курковых зон;
2. не соответствует зонам иннервации ветвей тройничного нерва;
3. чаще в области верхней челюсти, распространяется на периорбитальную область, нос, щёку, висок; бывает в одном зубе (атипичная одонталгия);
4. ночью обычно стихает, но у 50–70% нарушен сон;
5. обостряется от холода, стресса, хирургических и стоматологических вмешательств.

Миофасциальная боль со спазмом жевательной мышцы: внезапная боль и ограничение движений челюсти.

Синдром пылающего рта: постоянная жгучая боль на неизменённой слизистой, чаще языка, обычно двусторонняя, к вечеру сильнее; изменение вкуса и сухость во рту при нормальном слюноотделении.

Нейропатическая боль: негативные симптомы (гипестезия, анестезия) и позитивные (гипералгезия, аллодиния, гиперпатия, спонтанная боль, парестезии); аллодиния бывает механическая, температурная, двигательная. Постгерпетическая невралгия — жгучая, колющая боль с парестезией, гипералгезией, зудом, потерей чувствительности и аллодинией.

Нейропатическая боль: симптомы и механизмы

Симптом	Механизм
длительная жгучая боль	нарушение центрального тормозного контроля, центральная сенситизация, эктопические разряды
стреляющая, пронзающая боль	эктопические разряды
парестезия, дизестезия	эктопические разряды, центральная сенситизация
гипералгезия	центральная сенситизация от усиления ноцицептивной афферентации
механическая аллодиния	нарушение центрального торможения, центральная сенситизация, сенситизация ноцицепторов
парадоксальные реакции на температуру	нарушение центрального тормозного контроля
онемение, утрата чувствительности	дегенерация сенсорных волокон, нарушение центрального тормозного контроля

2.6 Клиническая картина: тригеминальные автономные цефалгии

Кластерная головная боль: односторонняя очень сильная боль в области глазницы, подглазничной или височной области, **15–180 минут**, чаще ночью; пациент возбуждён, не находит себе места.

Вегетативные симптомы на стороне боли

1. слезотечение (91%);
2. инъекция конъюнктивы (77%);
3. заложенность носа (75%);
4. птоз, отёк век, миоз;
5. ринорея;
6. потливость и покраснение лица.

Триггеры: алкоголь, вазодилататоры, нарушение сна, перепады давления (авиаперелёт, дайвинг), смена погоды, запахи.

Пароксизмальная гемикрания: сильная боль в области орбиты с вегетативными симптомами по **2–30 минут**, приступы в течение всего дня.

SUNCT и SUNA: короткие (секунды — минуты) приступы боли в области орбиты, часто от прикосновения к коже; при SUNA — чаще в виске, со слезотечением, заложенностью носа, ринореей, без рефрактерного периода (в отличие от тригеминальной невралгии).

Гемикрания континуа: односторонняя боль средней интенсивности с обострениями — в височной, глазничной, лобной, ретроорбитальной или затылочной области.

2.7 Клиническая картина: нейропатия лицевого нерва

Уровень поражения лицевого нерва

Уровень поражения	Симптомы, кроме слабости мимических мышц
мосто-мозжечковый угол	нарушение функции тройничного, отводящего и преддверно-улиткового нервов
внутренний слуховой проход	сухость глаза, нарушение вкуса на передних 2/3 языка, сухость во рту, снижение слуха на стороне поражения, головокружение
костный канал до отхождения большого каменистого нерва	сухость глаза, нарушение вкуса на передних 2/3 языка, сухость во рту, гиперакузия
до отхождения стремянного нерва	слезотечение, нарушение вкуса на передних 2/3 языка, сухость во рту, гиперакузия
выход через шилососцевидное отверстие	только двигательные нарушения и слезотечение
околоушная железа	только двигательные нарушения
отдельные ветви	только двигательные нарушения в зоне иннервации

Диагноз устанавливается по данным осмотра, МРТ и ЭНМГ. Паралич Белла развивается за **24–48 часов**, **максимум за 72 часа**.

Признаки уровня и причины

1. слабость только нижней группы мимических мышц — центральное поражение или поражение отдельных ветвей;
2. гиперакузия, нарушение вкуса, сухость во рту — периферическое поражение выше отхождения стремянного нерва;
3. снижение слуха на стороне поражения нехарактерно: следует заподозрить объёмное образование;
4. боль в ухе или за ухом — симптом идиопатической нейропатии или отогенного процесса;
5. рецидив встречается у 6,5% пациентов; нейропатия в анамнезе ставит под сомнение идиопатическую форму.

«Красные флаги» — нужны дополнительные исследования и консультации

1. симптомы нарастают **более 72 часов**;
2. тяжесть пареза колеблется;
3. слабы только мышцы нижней половины лица;
4. эпизод слабости мышц лица в анамнезе;
5. поражены обе половины лица;
6. снижение слуха;
7. головокружение;
8. другие неврологические симптомы.

У 60–70% пациентов функция восстанавливается полностью или частично **за 3–6 месяцев**, но из-за частых осложнений заболевание считают прогрессирующим и наблюдают.

Гипертонус мышц здоровой стороны развивается **с 7-го дня** у 67% пациентов, синкинезии — **с 4 месяцев до года**. Лагофтальм наблюдается у 3/4 пациентов и ведёт к ксерозу роговицы, кератиту, язве.

Первичные двигательные нарушения

1. снижение силы и тонуса мышц поражённой стороны;
2. лагофтальм.

Вторичные

1. гипертонус или контрактуры мышц здоровой или поражённой стороны;
2. атрофия мышц поражённой стороны;
3. синкинезии до постпаралитического гемиспазма.

Факторы риска контрактур и синкинезий

1. тяжёлое поражение: прозоплегия, по ЭНМГ поражение нерва **более 90%**;
2. активная стимуляция мышц: ЛФК с максимальной амплитудой движений, электростимуляция.

Изолированное поражение краевой нижнечелюстной ветви (после стоматологических и косметологических вмешательств, операций на голове и шее, травм) — асимметрия улыбки, ошибочно принимаемая за центральное поражение; выявляется пробой «Ы-Ы».

2.8 Клиническая картина: гемифациальный спазм и миокимия

Гемифациальный спазм: спонтанный односторонний клонический и (или) тонический спазм мышц лица, в покое и во сне; бывают щелчки в ухе (сокращение стременной мышцы) и боль как при невралгии тройничного нерва. Обычно начинается с круговой мышцы глаза. Двусторонний — менее 5%.

«Красные флаги» при лицевой миокимии

1. подёргивания и в других мышцах лица или тела;
2. двусторонний процесс;
3. глаз открывается с трудом, опущение века;
4. покраснение или отёк века, боль;
5. не проходит за несколько недель;
6. другие неврологические симптомы.

Непроизвольные движения лица

Состояние	Отличительный признак
Лицевая миокимия	периодические низкоамплитудные сокращения 1–2 мышц, проходят сами, заметнее пациенту

Состояние	Отличительный признак
Блефароспазм, лицевой параспазм	длительные прогрессирующие двусторонние скручивающие движения, вовлекаются соседние мышцы
Синкинезии	только при определённом движении: одна мышца провоцирует сокращение другой
Тики	дебют в 3–7 лет, прогрессируют только до подросткового возраста
Эпилепсия с миоклонией век (синдром Дживонса)	миоклония век с абсансами или без, дрожание век с двух сторон сразу после медленного закрытия

2.9 Клиническая картина: другие черепные нервы

Проявления поражения обонятельного, глазодвигательных и языкоглоточного нервов

1. **Обонятельный** — гипосмия, аносмия, гиперосмия
2. **Глазодвигательные** — птоз, косоглазие, диплопия, изменение ширины зрачка, нарушение конвергенции, аккомодации и сочетанных движений глаз
3. **Языкоглоточный**: при невралгии возникает пароксизмальная боль по типу удара тока в задней части языка, миндалине, глотке, у угла нижней челюсти и (или) в ухе; при нейропатии нарушается вкус задней трети языка и снижается чувствительность верхней половины глотки; при болевой нейропатии боль постоянна и ограничена зоной нерва

Проявления поражения блуждающего, добавочного и подъязычного нервов

1. **Блуждающий** поражается редко изолированно; проявляется парезом мышц глотки и голосовых складок (дисфагия, дисфония, дизартрия), тахи- или брадикардией, а при двустороннем поражении — нарушением ритма дыхания
2. **Добавочный**: голова отклонена в больную сторону, ограничен поворот в здоровую, затруднено поднимание плеч; позже развивается атрофия грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц
3. **Подъязычный**: парез половины языка, язык отклоняется в сторону поражения; при ядерном поражении возникают атрофия и фибриллярные подёргивания, при двустороннем — глоссоплегия, дизартрия или анартрия

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз тригеминальной невралгии клинический. Нейроваскулярный конфликт на МРТ сам по себе не является основанием для диагноза классической невралгии. Это относится и к невралгии языкоглоточного нерва.

Общепринятых критериев для поражений лицевого нерва нет: диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, осмотра и инструментальных данных. Задача обследования — установить уровень поражения, причину, тяжесть и прогноз восстановления.

Поражения обонятельного нерва, нервов глазодвигательной и каудальной групп диагностируют по жалобам и данным неврологического осмотра; необходимо выявить основное заболевание.

Критерии диагноза: атипичная лицевая боль

Форма	Критерии
Персистирующая идиопатическая лицевая боль	ежедневно **более 2 часов** **более 3 месяцев**; плохо локализована, не соответствует зоне нерва; тупая, ноющая или тянущая; обследование патологии не выявляет
Миофасциальная боль со спазмом	спазм жевательной мышцы, боль связана со спазмом по времени и динамике; боль в челюсти, виске, ухе или перед ухом, вызывается пальпацией мышцы или открыванием рта
Синдром пылающего рта	ежедневно **более 2 часов** **более 3 месяцев**; жжение поверхностно в слизистой; слизистая не изменена, местные и системные причины исключены

Критерии диагноза: тригеминальная нейропатическая боль

Форма	Критерии
Связанная с Herpes zoster	односторонняя боль **менее 3 месяцев**; высыпания в зоне нерва или VZV в ликворе (ПЦР) или в материале из очагов; бывает без высыпаний (zoster sine herpete)
Постгерпетическая невралгия	боль **более 3 месяцев** в зоне ветвей, поражённых Herpes zoster, связана с ним по времени
Посттравматическая	боль **более 3 месяцев**, повреждение нерва в анамнезе и по исследованиям, начало **не позднее 6 месяцев** после травмы, соматосенсорные симптомы в той же зоне; часто — после стоматологического лечения
Связанная с другим нарушением	боль 3 месяца и более, есть способное её вызвать расстройство, соматосенсорные симптомы в зоне боли
Идиопатическая	боль 3 месяца и более с соматосенсорными симптомами, поражение нерва есть, травмы и другой причины нет

Критерии диагноза: тригеминальные автономные цефалгии

Форма	Критерии
Кластерная головная боль	не менее 5 атак; сильная односторонняя боль в глазничной, подглазничной и (или) височной области **15–180 минут**; на стороне боли — инъекция конъюнктивы или слезотечение, заложенность носа или ринорея, отёк век, потливость лица, миоз или птоз, и (или) беспокойство; от 1 раза в 2 дня до 8 раз в день
Пароксизмальная гемикрания	не менее 20 атак по **2–30 минут**, более 5 в день, те же вегетативные симптомы, полностью проходит от индометацина
SUNCT	не менее 20 атак **1–600 секунд**, с вегетативными симптомами, не реже раза в день
SUNA	не более одного из симптомов: инъекция конъюнктивы, слезотечение
Гемикрания континуа	односторонняя боль **более 3 месяцев** с обострениями, вегетативные симптомы (в том числе ощущение распирания в ухе), абсолютный эффект индометацина

3.2 Жалобы и анамнез

Нейропатия лицевого нерва

При асимметрии лица вследствие слабости мимических мышц необходим активный сбор жалоб и анамнеза, включая эпидемиологический, для определения уровня поражения (центральный или периферический) и причины.

Уточнить

1. длительность и скорость развития, порядок появления симптомов;
2. слабость верхней и нижней групп мимических мышц;
3. гиперакузию, нарушение вкуса, сухость во рту;
4. боль в ухе или за ухом накануне или в начале асимметрии;
5. травмы, операции, косметологические и стоматологические вмешательства;
6. гипертоническую болезнь, сахарный диабет, неврологические заболевания, беременность;
7. лихорадку, увеличение лимфатических узлов, покраснение или отёк тканей головы и шеи;
8. высыпания на лице, в околоушной области, в ушной раковине;
9. пребывание в регионах клещевого энцефалита **в течение месяца** до начала.

При наличии «красных флагов» показано расширенное клинико-лабораторное и инструментальное обследование.

Лицевая боль

«Красные флаги» при лицевой боли — признаки вторичной природы

1. внезапное начало;
2. лихорадка, сыпь, менингеальные симптомы;
3. боль усиливается при перемене положения, нагрузке, кашле, чихании;
4. нарастающая боль, резистентная к лечению;
5. боль впервые **после 50 лет**;
6. изменения неврологического статуса;
7. необъяснимая потеря веса, гипергидроз;
8. онкологическое заболевание, иммунодефицит, длительный приём глюкокортикоидов.

Диагноз атипичной лицевой боли устанавливается по критериям Международной классификации орофациальной боли.

При боли в зоне ветвей тройничного нерва собирают анамнез и жалобы, оценивают боль и чувствительные нарушения в лице. Нейропатический характер боли подтверждают опросниками DN-4, painDETECT, LANSS.

3.3 Неврологический осмотр

Нейропатия лицевого нерва

Невролог выполняет осмотр с пальпацией околоушных слюнных желёз и лимфатических узлов.

Оценивают силу каждой мимической мышцы, тонус на обеих сторонах, смещение средней линии лица, синкинезии: это позволяет определить уровень и степень поражения.

Тяжесть поражения оценивают по шкале House-Brackmann с записью в медицинскую документацию; для наблюдения в динамике используют более чувствительную шкалу Sunnybrook.

Для ранней профилактики осложнений и направления к офтальмологу оценивают лагофтальм: смыкание век спокойно и с усилием, расстояние между веками в мм, положение век, инъекцию конъюнктивы.

Повторный осмотр невролога в течение нескольких месяцев после начала восстановления необходим для профилактики и лечения осложнений, в том числе глазных.

Проверка мимических мышц

Мышца	Проба
лобное брюшко надчерепной мышцы	поднять брови
мышца, сморщивающая бровь	нахмуриться
круговая мышца глаза, вековая часть	спокойно закрыть глаза
круговая мышца глаза, орбитальная часть	зажмуриться
мышцы, поднимающие верхнюю губу, крыло носа, угол рта	показать «оскал»
малая и большая скуловые	сомкнуть губы и улыбнуться
щёчная	надуть щёки
мышца смеха	широко улыбнуться с разомкнутыми губами
круговая мышца рта	вытянуть губы трубочкой
опускающая угол рта	грустная улыбка
опускающая нижнюю губу	опустить губу, сказать «Ы-Ы»
подбородочная	поднять нижнюю губу
подкожная мышца шеи	сказать «Ы-Ы» и напрячь шею

Патологические синкинезии

Синкинезия	Проявление
оро-окулярная	при вытягивании губ, надувании щёк, жевании сужается глазная щель
окуло-фронтальная	при моргании и зажмуривании морщится лоб
окуло-скуловая	при моргании и зажмуривании углубляется носогубная складка
окуло-назальная	при моргании и зажмуривании сокращается носовая мышца (может быть физиологической)
синкинезия Гюйе	при зажмуривании крыло носа поднимается вверх и кнаружи
окуло-оральная	при моргании и зажмуривании сокращаются носогубная складка, скуловые мышцы, верхняя губа
окуло-платизменная	зажмуривание напрягает подкожную мышцу шеи
окуло-аурикулярная	при зажмуривании поднимается ушная раковина
фронто-назальная	поднимание бровей сокращает носовую мышцу
фронто-оральная	при наморщивании лба сокращается угол рта
синкинезия Марина-Амата	открывание рта или боковые движения челюсти закрывают веки (редко)
«крокодиловы слёзы»	слезотечение на поражённой стороне при жевании

Синкинезия	Проявление
окуло-стапедиальная	при моргании и закрывании глаз — одностороннее снижение слуха или шум в ухе
звукоиндуцированная	звуки (клавиши, хлопки, труба) вызывают сокращение мимических мышц
ретроаурикулярная боль	хроническая боль за ухом во время менструации после паралича Белла

Гемифациальный спазм и лицевая миокимия

При гемифациальном спазме невролог выполняет осмотр с пальпацией околоушных желёз и лимфатических узлов, оценивает все мимические мышцы и непроизвольные движения; возможны прозопарез и гипертонус.

При лицевой миокимии выполняют такой же осмотр для выявления «красных флагов».

Невралгия языкоглоточного нерва

При подозрении на невралгию языкоглоточного нерва неврологический осмотр с пальпацией позволяет исключить вторичную причину.

Тройничный нерв и лицевая боль

При тригеминальной невралгии невролог исследует чувствительность в зонах ветвей тройничного нерва, выполняет бимануальную пальпацию жевательных мышц и провокацию боли с триггерных точек для исключения симптоматической невралгии, дисфункции ВНЧС, миофасциальной боли.

При атипичной лицевой боли оценивают неврологический, соматический и местный статус; при «красных флагах» проводят поиск причин вторичной боли.

Осмотр головы и шеи: повреждения и цвет кожи, отёк; пальпация лимфатических узлов и слюнных желёз. Пальпация мышц лица с усилием **1 кг**: **2 секунды** — местная боль, **5 секунд** — отражённая.

При подозрении на тригеминальную нейропатическую боль исследуют чувствительность в зонах ветвей, корнеальный рефлекс, отмечают депигментацию или пигментацию кожи лица.

При сомнительном диагнозе тригеминальной нейропатической боли бимануальная пальпация жевательных и височных мышц позволяет исключить дисфункцию ВНЧС.

При впервые возникшей боли в зоне глазничной ветви у пациентов **после 50 лет** с эпизодами amaurosis fugax пальпируют поверхностную височную артерию для исключения гигантоклеточного артериита.

При тригеминальных автономных цефалгиях осмотр невролога необходим для исключения вторичного характера головной боли.

3.4 Анализы крови

Нейропатия лицевого нерва

Развёрнутый общий анализ крови: сдвиг лейкоцитарной формулы в сторону нейтрофилов свидетельствует о неблагоприятном прогнозе.

Биохимический анализ крови с определением глюкозы натощак позволяет исключить метаболические причины.

При сахарном диабете определяют гликированный гемоглобин для оценки компенсации диабета, поскольку таким пациентам необходимы высокие дозы глюкокортикоидов.

При подозрении на инфекционную причину в начале заболевания определяют антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, вирусу простого герпеса, VZV, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна — Барр, вирусу герпеса 6 типа.

При подозрении на клещевой энцефалит определяют антитела к вирусу клещевого энцефалита.

Определяют уровень ТТГ: при гипотиреозе риск нейропатии лицевого нерва выше.

Гемифациальный спазм и лицевая миокимия

При гемифациальном спазме для исключения вторичных форм выполняют общий и биохимический анализ крови с определением глюкозы.

При лицевой миокимии анализы крови показаны только при наличии «красных флагов».

Тройничный нерв и лицевая боль

Синдром пылающего рта: анализы крови

1. общий и биохимический с глюкозой;
2. витамин B12, фолиевая кислота;
3. гемоглобин, железо, ферритин, трансферрин;
4. эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон.

Дефицит питания, диабет, климактерические нарушения указывают на вторичный синдром.

Не рекомендуется определять антитела к VZV для подтверждения постгерпетической невралгии: они слишком распространены в популяции.

При боли в зоне глазничной ветви у пациентов **старше 50 лет** с amaurosis fugax определяют СРБ и СОЭ; значимыми считаются СОЭ **≥ 50 мм/ч** или СРБ **≥ 10 мг/л**.

3.5 Магнитно-резонансная томография

Нейропатия лицевого нерва

При сочетании с другими неврологическими симптомами для исключения инсульта экстренно выполняют КТ или МРТ. При типичной картине экстренная МРТ не требуется.

Показания

1. симптомы сохраняются **более 3 недель**;
2. «красные флаги».

Выполняют МРТ головного мозга с контрастным усилением по расширенному протоколу, по возможности с захватом околоушной железы. При невозможности МРТ выполняется КТ с контрастным усилением.

Исследование позволяет исключить

1. объёмное образование;
2. воспаление, демиелинизацию;
3. инсульт;
4. нейроваскулярный конфликт.

При типичной картине объёмное образование находят в **8–12%**, из них 30% злокачественные. У 80% выздоравливающих восстановление начинается **в первые 2–3 недели**.

При тяжёлом поражении, сохраняющемся **более 3 месяцев**, и подозрении на атрофию выполняют МРТ мягких тканей лица, прежде всего скуловых мышц: при тотальном поражении атрофия развивается быстро, и позднее хирургическое лечение может оказаться нецелесообразным.

Невралгия языкоглоточного нерва

Всем пациентам показана МРТ головного мозга с захватом краниовертебрального перехода в режиме 3D SPGR. После исключения вторичных причин выполняют режимы FIESTA и 3D TOF для подтверждения классической невралгии.

Гемифациальный спазм и лицевая миокимия

Всем пациентам с гемифациальным спазмом показана МРТ по расширенному протоколу (3D-T2, 3D-TOF, FIESTA и др.) для выявления нейроваскулярного конфликта.

Если на бесконтрастных сериях конфликт не выявлен, выполняют МРТ с контрастным усилением для исключения опухоли и других причин.

При лицевой миокимии с «красными флагами» показана МРТ с контрастным усилением; без них МРТ **не рекомендуется**.

Тройничный нерв, лицевая боль и тригеминальные автономные цефалгии

При тригеминальной невралгии всем пациентам показана обзорная МРТ в режиме 3D SPGR для исключения опухоли и демиелинизации; при подозрении на них исследование выполняют с контрастным усилением.

При фармакорезистентности, непереносимости или низкой приверженности лечению МРТ в режимах FIESTA и 3D TOF позволяет подтвердить или исключить нейроваскулярный конфликт.

Конфликт диагностируют при структурных изменениях корешка (дистопия, атрофия). Толщина среза **0,4–0,6 мм**, аппарат лучше 3 Тл, не менее 1,5 Тл.

При впервые выявленной атипичной лицевой боли с «красными флагами» показана МРТ головного мозга.

При атипичной картине лицевой боли, «красных флагах» и изменениях неврологического статуса выполняют МРТ головного мозга, мягких тканей головы, шейного отдела позвоночника и шеи.

Дифференциальный диагноз: патология костей черепа, болезни уха, синусит, патология челюстей, зубов, ВНЧС, краниальных нервов, тригеминальная и языкоглоточная невралгия, невралгия промежуточного нерва, внутричерепные опухоли и опухоли полости рта и др.

При возможной посттравматической, возможной связанной с другим нарушением и идиопатической тригеминальной нейропатической боли выполняют обзорную МРТ.

При впервые возникших приступах SUNCT или SUNA МРТ позволяет исключить очаговое поражение головного мозга.

При впервые выявленной кластерной головной боли или пароксизмальной гемикрании показана МРТ с контрастным усилением для исключения опухоли, мальформации и воспаления; при гемикрании континуа также выполняют МРТ.

Кластерную головную боль отличают от других цефалгий, мигрени, височного артериита, тригеминальной невралгии, синусита, глаукомы, опухоли, мальформации, инсульта, диссекции артерий.

3.6 КТ височной кости и другие лучевые исследования

Нейропатия лицевого нерва

При подозрении на ЛОР-патологию или травму височной кости показана КТ височной кости; при невозможности КТ выполняется рентгенография височной кости.

Невралгия языкоглоточного нерва

Если МРТ не выявила причину, выполняют КТ краниовертебрального перехода.

Диагностические признаки

1. удлинённый шиловидный отросток;
2. кальцинированная шилоподъязычная связка.

При подозрении на вторичную невралгию или нейропатическую боль языкоглоточного нерва, если МРТ головы причину не выявила, показана МРТ мягких тканей шеи с контрастным усилением и жироподавлением.

Тройничный нерв и лицевая боль

При возможной связанной с другим нарушением и идиопатической тригеминальной нейропатической боли для исключения одонтогенных причин и синусита выполняют ОПТГ, КЛКТ и (или) КТ или рентгенографию околоносовых пазух.

При лицевой боли, не отвечающей критериям тригеминальной невралгии, по клинической картине назначают ОПТГ, КЛКТ, МРТ ВНЧС, УЗИ слюнных желёз, осмотр и пальпацию мышц.

3.7 Видеоларингоскопия

При невралгии языкоглоточного нерва видеоларингоскопия показана всем пациентам для уточнения причины.

3.8 Ультразвуковое исследование

Нейропатия лицевого нерва

При нейропатии неясной причины, сохраняющейся **более 3 недель**, если выполнение МРТ затруднено, показано УЗИ околоушной слюнной железы.

При тяжёлом поражении по данным ЭНМГ, сохраняющемся **более 3 месяцев**, УЗИ мягких тканей лица выявляет атрофию мышц и позволяет своевременно направить пациента к хирургу.

Невралгия языкоглоточного нерва

При невралгии языкоглоточного нерва всем пациентам показано УЗИ слюнных желёз и мягких тканей шеи.

Гемифациальный спазм

При гемифациальном спазме неясной причины выполняют УЗИ околоушной слюнной железы (или МРТ).

3.9 Электронейромиография и электромиография

Нейропатия лицевого нерва

Показания

1. тяжёлая нейропатия (V–VI степень по House-Brackmann).

Стимуляционную ЭНМГ выполняют **не ранее 8 суток**, предпочтительно **на 9–20 день**, с обеих сторон (круговые мышцы глаза и рта).

Диагностические признаки

1. снижение амплитуды М-ответа на поражённой стороне **на 90% и более** свидетельствует о неблагоприятном прогнозе и служит показанием к игольчатой ЭМГ.

При асимметрии М-ответа более 90% выполняют игольчатую ЭМГ не менее двух мышц верхней и нижней порций. Отсутствие потенциалов двигательных единиц при произвольном сокращении свидетельствует о тотальном поражении, неблагоприятном прогнозе и является показанием к операции.

Отсутствие потенциалов двигательных единиц может не иметь прогностического значения **до 15 дня**, поэтому исследование повторяют.

При изолированном поражении ветви выполняют игольчатую ЭМГ плегированной мышцы (например, опускающей нижнюю губу). При травме потенциалы могут появиться только на 4-м месяце.

Если тяжёлая нейропатия сохраняется, игольчатую ЭМГ повторяют **через 6 месяцев** (при отсутствии восстановления и травмы — **через 3 месяца**) для решения вопроса об операции.

При неполном поражении (**менее IV степени**) и сохранённых движениях во всех ветвях ЭНМГ и ЭМГ **не рекомендуются**: прогноз благоприятный.

Тройничный нерв и лицевая боль

При миофасциальной боли со спазмом и недостатке данных выполняют накожную ЭМГ: регистрируются потенциалы двигательных единиц в покое.

При возможной и идиопатической тригеминальной нейропатической боли, если повреждение не подтверждено другими методами, исследуют коротколатентные вызванные потенциалы тройничного нерва.

3.10 Количественное сенсорное тестирование

При персистирующей идиопатической лицевой боли с подозрением на сенсорные нарушения показано количественное сенсорное тестирование.

При тригеминальной нейропатической боли количественное сенсорное тестирование позволяет объективизировать нарушения.

3.11 Консультация оториноларинголога

Показания

1. при нейропатии лицевого нерва всем пациентам показан осмотр с отоскопией для исключения отогенной причины, по показаниям — аудиометрия и тимпанометрия.

Диагностические признаки

1. кондуктивная тугоухость позволяет предположить опухоль лицевого нерва в пирамиде височной кости;
2. нейросенсорная тугоухость позволяет предположить сдавление нерва объёмным образованием в мосто-мозжечковом углу.

Тимпанометрия оценивает акустический рефлекс стременной мышцы.

При подозрении на лицевую боль, связанную с заболеванием околоносовых пазух (при тригеминальной невралгии и поражениях других черепных нервов), показана консультация оториноларинголога.

3.12 Другие консультации

Нейропатия лицевого нерва

При неосложнённом лагофтальме консультация офтальмолога проводится планово, при **осложнённом** (покраснение, жжение, боль, светобоязнь, дефекты роговицы) — **экстренно**.

При подозрении на инфекционную природу нейропатии показана консультация инфекциониста.

Консультация психолога показана при социальной дезадаптации, неприятии внешности, тревоге, апатии, нарушениях сна; при суицидальных мыслях необходима консультация психиатра.

При тяжёлой нейропатии (V–VI степень) или осложнениях (гипертонус, синкинезии) консультация врача ЛФК обязательна; остальным пациентам достаточно домашней самореабилитации.

Стоматолог и челюстно-лицевой хирург

Консультация стоматолога показана при сомнительном диагнозе тригеминальной невралгии или невралгии языкоглоточного нерва, всем пациентам с синдромом пылающего рта и персистирующей идиопатической лицевой болью, а также при подозрении на одонтогенную нейропатическую боль.

При синдроме пылающего рта слизистая оболочка должна быть без изменений; при эрозиях и язвах, не заживающих **2 недели**, выполняют биопсию.

При подозрении на боль, связанную с травмами и другими заболеваниями челюстно-лицевой области, показана консультация челюстно-лицевого хирурга.

Психиатр и медицинский психолог

Консультация психиатра необходима при тревоге, депрессии и во всех случаях сомнительной тригеминальной невралгии после исключения орофациальной боли.

При синдроме пылающего рта с тревогой, депрессией или болью **более 3 месяцев** пациента направляют к психиатру.

Пациентам с персистирующей идиопатической лицевой болью при тревоге, депрессии или хронической боли также показана консультация психиатра.

Миофасциальная боль со спазмом в сочетании с тревогой, депрессией или хронической болью служит поводом для консультации психиатра.

При тригеминальной нейропатической боли с тревогой и депрессией рекомендована консультация психиатра.

При хронической тригеминальной нейропатической боли медицинский психолог оценивает факторы хронизации.

Нейрохирург

При тригеминальной невралгии с фармакорезистентностью, непереносимостью или низкой приверженностью лечению показана консультация нейрохирурга.

При тригеминальной нейропатической боли с фармакорезистентностью или непереносимостью лечения нейрохирург решает вопрос о пункционных и хирургических методах.

Невралгия языкоглоточного нерва с фармакорезистентностью или непереносимостью лечения также является показанием к консультации нейрохирурга.

Другие специалисты

При подозрении на демиелинизирующее заболевание по данным МРТ показана консультация невролога кабинета рассеянного склероза.

При нейропатической боли, связанной с Herpes zoster, показана консультация дерматовенеролога и (или) инфекциониста, при глазничной локализации — офтальмолога.

При боли в зоне глазничной ветви у пациентов **старше 50 лет** с amaurosis fugax ревматолог исключает гигантоклеточный артериит.

3.13 Направление к хирургу

Нейропатия лицевого нерва

Операцию проводят при неблагоприятных клинических и миографических признаках; её вид зависит от давности заболевания.

Вид операции по давности заболевания

1. менее **3 месяцев** при идиопатической форме: патогенетическое лечение — декомпрессия лабиринтного сегмента нерва;
2. до **18 месяцев** при любой форме: реиннервирующая операция;
3. позже: реконструктивно-пластическая операция.

При идиопатической нейропатии тяжёлой степени консультация нейрохирурга показана как можно раньше, но после ЭНМГ и ЭМГ (**не ранее 8 суток**), для решения вопроса о декомпрессии.

Отбирают пациентов с V–VI степенью и разницей М-ответа **более 90%** после исключения рецидивов и других причин. Декомпрессию предпочтительно выполнять **в течение 14 дней** через среднюю черепную ямку; возможна она и **до 3 месяцев**. При положительной динамике операцию не проводят.

При тяжёлой нейропатии, сохраняющейся **после 3 месяцев** (идиопатической или симптоматической), показана консультация челюстно-лицевого хирурга для решения вопроса о реиннервирующей (до 18 месяцев) или реконструктивно-пластической операции; учитывают атрофию мышц по данным УЗИ или МРТ.

При постпаралитическом гемиспазме с выраженными синкинезиями челюстно-лицевой хирург решает вопрос о селективной нейрэктомии; при лёгком и умеренном гемиспазме применяют ботулинический токсин и реабилитацию.

Гемифациальный спазм

При первичном гемифациальном спазме с нейроваскулярным конфликтом на МРТ показана консультация нейрохирурга для решения вопроса о васкулярной декомпрессии.

При вторичном гемифациальном спазме с объёмным образованием на МРТ нейрохирург определяет показания к операции.

---

4. Лечение

4.1 Тригеминальная невралгия: подходы

Применяют три подхода: консервативную терапию (профилактическое лечение и купирование приступов), малоинвазивные вмешательства и операции.

Всем пациентам с установленным диагнозом показана профилактическая терапия для урежения приступов. Препаратами первой линии являются карбамазепин и окскарбазепин; остальные препараты относятся ко второй линии и применяются отдельно или вместе с препаратами первой линии.

Общие рекомендации по ведению пациентов

1. лечение начинают с монотерапии; при необходимости комбинации препараты добавляют поочерёдно, чтобы оценить переносимость каждого;
2. препарат заменяют постепенно, согласно инструкции;
3. при ремиссии (отсутствии боли **не менее 4 недель**) дозу медленно снижают, возможна полная отмена;
4. при рецидиве лечение постепенно возобновляют до минимальной эффективной дозы;
5. на фоне противоэпилептических препаратов контролируют показатели крови **каждые 3–6 месяцев**: общий анализ, биохимический (глюкоза, ЩФ, АЛТ, АСТ, билирубин), натрий, калий; по показаниям — ЭКГ и концентрацию препарата в крови;
6. если любое лечение не даёт обезболивающего эффекта при хорошей переносимости, рекомендуют консультацию психиатра;
7. для направления к нейрохирургу нет необходимости перебирать все препараты.

Профилактическое лечение тригеминальной невралгии

Препарат	Схема	Доза в сутки	Частые побочные эффекты
карбамазепин	100 мг 2 раза в день, повышать на 100–200 мг каждые 3 дня до 200 мг 4 раза в день	800–1200 мг	седация, головокружение, нечёткость зрения, тошнота, неустойчивость, вялость, диплопия, головная боль; гипонатриемия, кожная сыпь, панцитопения; остеопороз при длительном приёме; снижает эффективность оральных контрацептивов

Препарат	Схема	Доза в сутки	Частые побочные эффекты
#окскарбазепин	150 мг 2 раза в день, повышать на 150–300 мг каждые 3 дня до 300 мг 4 раза в день	1200–1800 мг	сонливость, головокружение, диплопия, спутанность сознания, тошнота, боль в животе, головная боль, депрессия, диарея; высокий риск гипонатриемии; остеопороз при регулярном приёме; снижает эффективность оральных контрацептивов
#ламотриджин	25 мг 1 раз в день, повышать на 25 мг каждые 2 недели, после 100 мг — каждую неделю; свыше 100 мг — в 2 приёма	200 мг	нечёткость зрения, возбуждение, агрессия, неустойчивость, головокружение, тошнота, сухость во рту, бессонница, боль в суставах; сыпь и синдром Стивенса — Джонсона при быстром повышении дозы; можно отменять без титрации
#баклофен	5 мг 3 раза в день, повышать на 5 мг каждые 3 дня	40–80 мг	тревога, депрессия, возбуждение, неустойчивость, головная боль, седация, тремор, кожная сыпь, нечёткость зрения, сухость во рту, боль в животе; синдром отмены при слишком быстром прекращении
#габапентин	300 мг 1 раз в день, повышать на 300 мг ежедневно до 900 мг, затем на 300 мг каждые 3–5 дней	900–3600 мг	амнезия, спутанность сознания, головокружение, сонливость, депрессия, тошнота, нечёткость зрения, периферические отёки и отёки лица, запор, вздутие живота, прибавка веса
#прегабалин	75 мг 2 раза в день	600 мг	спутанность сознания, сонливость, запор, нечёткость зрения, головокружение, тошнота, периферические отёки и отёки лица, повышение аппетита, прибавка веса

Каждый из препаратов таблицы рекомендован отдельно; при непереносимости #баклофена можно рассмотреть назначение #клоназепама. Пометка off-label (в КР — знак #) — применение вне инструкции.

Опиоиды для профилактического лечения **не рекомендуются**.

Дополнительно применяют ботулинический токсин типа А: 1,25–5 ЕД внутрикожно в триггерные точки с интервалом 15–20 мм, всего 25–100 ЕД.

Дополнительным методом является высокочастотная ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция.

4.2 Тригеминальная невралгия: купирование приступа

Для купирования острой боли используют местные анестетики. Перед блокадой ветви выполняют кожную пробу.

Купирование приступа

Препарат	Применение
#лидокаин	10% спрей — 2 впрыскивания в носовой ход на стороне боли (частое применение повреждает слизистую из-за спирта); 5% гель на триггерную зону; 2% раствор с #эпинефрином 1:80 000 — блокада ветви; внутривенно 1,5–5 мг/кг дольше 1 часа

Препарат	Применение
#ботулинический токсин типа А	50 ЕД в 1,0 мл 0,9% раствора натрия хлорида подкожно в триггерные точки

НПВП при тригеминальной невралгии **не рекомендуются**, так как при невропатической боли неэффективны. Если боль всё же купируется НПВП, следует исключить локальные воспалительные процессы.

4.3 Тригеминальная невралгия: хроническая боль

При хронической боли применяют #амитриптилин.

Альтернативным препаратом является #дулоксетин.

Возможно также назначение #венлафаксина.

Хроническая боль при тригеминальной невралгии

Препарат	Схема	Доза в сутки	Частые побочные эффекты
#амитриптилин	с 5–6,25 мг вечером за полтора часа до сна, повышать на 5–6,25 мг каждые 3–5 дней	12,5–75 мг	седация, сухость во рту, затруднение мочеиспускания, запор, нечёткость зрения, диплопия, повышение внутриглазного давления, нарушение памяти, тремор, аритмия
#дулоксетин	30 мг утром 1–2 недели, затем 60 мг утром	60 мг	головокружение, сонливость или бессонница, сухость во рту, тошнота, запор, потливость, снижение массы тела
#венлафаксин	с 18,75 мг 2 раза в день во время еды, повышать на 18,75 мг каждые несколько дней; после 75 мг — на 37,5 мг	75–225 мг	тошнота, снижение аппетита, запор, снижение массы тела, артериальная гипертензия, головокружение, бессонница, парестезии, тремор, нечёткость зрения, сексуальная дисфункция, потливость, высокая вероятность синдрома отмены

Психотерапия (когнитивно-поведенческая терапия, биологическая обратная связь, релаксация, майндфулнесс) уменьшает тревогу, депрессию и катастрофизацию боли.

4.4 Тригеминальная невралгия: малоинвазивные вмешательства

При классической невралгии в зоне надглазничного нерва и недостаточном эффекте лечения выполняют термическую радиочастотную абляцию надглазничного нерва под контролем КТ или УЗИ после диагностической блокады.

В зоне подглазничного нерва применяют импульсную и (или) термическую радиочастотную абляцию подглазничного нерва под контролем КТ после диагностической блокады.

При идиопатической или симптоматической невралгии, если лечение основного заболевания не помогло или невозможно, выполняют микробаллонную компрессию гассерова узла.

В той же ситуации возможна термическая радиочастотная абляция тройничного нерва.

Альтернативой является глицериновая ризотомия.

4.5 Тригеминальная невралгия: операции

При фармакорезистентности или непереносимости лечения показано нейрохирургическое лечение в специализированном отделении. Операцию в первые 2 года выбирают 25–40% пациентов.

Классическая невралгия

Методом выбора является микроваскулярная декомпрессия корешка (ретросигмоидный доступ), если на МРТ выявлен конфликт со структурными изменениями корешка; у пациентов **старше 75 лет** решение принимается индивидуально.

Если декомпрессия невозможна или пациент от неё отказался, выполняют стереотаксическую радиохирургию корешка (до **90 Гр**, предпочтительно «Гамма-нож»); повторно — **не ранее 1 года**.

При отсутствии эффекта лечения возможна имплантация нейростимулятора после тестовой стимуляции.

Идиопатическая невралгия

Применяют стереотаксическую радиохирургию.

При неэффективности других методов выполняют частичную сенсорную ризотомию.

Другой вариант при неэффективности остальных методов — имплантация нейростимулятора после тестовой стимуляции.

Невралгия при рассеянном склерозе

Применяют стереотаксическую радиохирургию; при её неэффективности выполняют медиальную таламотомию.

При неэффективности других методов возможна частичная сенсорная ризотомия.

При нейроваскулярном конфликте и изменениях корешка выполняют микроваскулярную декомпрессию. Эффективность методов равноценна, но безопаснее радиохирургия и пункционные вмешательства.

Если другие методы неэффективны, рассматривается имплантация нейростимулятора.

Симптоматическая невралгия

Выполняют операцию по поводу причины (например, удаление опухоли) с декомпрессией корешка.

Если после лечения причины боль не регрессирует, применяют стереотаксическую радиохирургию.

При неэффективности других методов возможна частичная сенсорная ризотомия.

Ещё один вариант при неэффективности остальных методов — имплантация нейростимулятора.

4.6 Атипичная лицевая боль: лекарства

Персистирующая идиопатическая лицевая боль

Препаратом первого выбора является #амитриптилин: 6,25–12,5 мг вечером с повышением на 6,25–12,5 мг каждые 3–14 дней до 10–75 мг.

При противопоказаниях, плохой переносимости или неэффективности трициклических антидепрессантов назначают #венлафаксин: 18,75 мг 2 раза в день во время еды с повышением на 18,75 мг каждые несколько дней до 75 мг.

Если не подошёл и венлафаксин, применяют #флуоксетин 20 мг 1 раз в день.

При неэффективности или непереносимости антидепрессантов используют габапентин (300 мг 1 раз в день с повышением до 900–3600 мг) или прегабалин (75 мг 2 раза в день, до 600 мг).

При недостаточном эффекте лекарственной терапии вводят ботулинический токсин типа А в область боли.

Синдром пылающего рта

Применяют #амитриптилин с минимальной дозы на ночь, в среднем 10–50 мг в сутки.

Эффективен также габапентин.

Назначают #альфа-липоевую (тиоктовую) кислоту 600 мг в сутки; в сочетании с габапентином она эффективнее.

Миофасциальная боль

При миофасциальной боли со спазмом применяют НПВП, предпочтительно внутрь, без комбинирования, **10–14 дней**; учитывают риск осложнений со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

При хронической миофасциальной боли назначают #амитриптилин с 10 мг на ночь, до 150 мг в сутки.

При неэффективности антидепрессантов применяют #габапентин с 300 мг с повышением на 300 мг каждые 3 дня до 4200 мг.

Возможно введение ботулинического токсина типа А в поражённые мышцы.

4.7 Атипичная лицевая боль: психотерапия и вмешательства

При персистирующей идиопатической лицевой боли применяют когнитивно-поведенческую терапию.

При синдроме пылающего рта показаны когнитивно-поведенческая терапия и психотерапия.

При миофасциальной боли используют биологическую обратную связь для мышечного и психологического расслабления.

Пациентам с миофасциальной болью рекомендована также когнитивно-поведенческая терапия.

При персистирующей идиопатической лицевой боли без эффекта лекарственной терапии выполняют импульсную радиочастотную абляцию крылонёбного узла после положительной блокады (подскуловой доступ).

4.8 Тригеминальная нейропатическая боль

Медикаментозное лечение

Применяют габапентин (300 мг 1 раз в день с повышением до 900–3600 мг) или прегабалин (75 мг 2 раза в день, до 600 мг) отдельно или в комбинации.

#Окскарбазепин назначают с 300 мг с повышением на 300 мг каждые 3 дня до 1800 мг в 2 приёма.

Антидепрессанты применяют отдельно или в комбинации с препаратами других групп; каждый из трёх препаратов таблицы рекомендован и отдельно (А, 1).

Антидепрессанты при нейропатической боли

Препарат	Схема	Доза в сутки
#амитриптилин	с 5–6,25 мг вечером за полтора часа до сна, повышать на 5–6,25 мг каждые 3–5 дней	75 мг
#дулоксетин	30 мг утром 1–2 недели, затем 60 мг утром	60 мг
#венлафаксин	9,375–18,75 мг 2 раза в день, повышать на 9,375–18,75 мг каждые 3–7 дней	75–225 мг

Дополнительная терапия

Дополнительно используют пластырь с 5% #лидокаином или гель с #лидокаином на область боли.

Опиоиды относятся к третьей линии из-за риска зависимости: тапентадол (В, 2), налоксон + оксикодон, трамадол, морфин (А, 1); доза подбирается индивидуально.

Возможно дополнительное назначение #альфа-липоевой (тиоктовой) кислоты 600 мг в сутки.

Применяют психотерапию: когнитивно-поведенческую, биологическую обратную связь, релаксацию, майндфулнесс.

Дополнительно вводят ботулинический токсин типа А в зоне боли.

Ещё один дополнительный метод — ритмическая ТМС 5–20 Гц, 5–10 сеансов, на моторную или дорсолатеральную префронтальную кору.

При постгерпетической невралгии и посттравматической боли гипербарическая оксигенация (не менее 10 сеансов) уменьшает аллодинию и зуд.

Лечение лучевых изменений при посттравматической тригеминальной нейропатической боли после облучения

1. **#альфа-токоферола ацетат** — при дозе свыше 400 мг в сутки одновременно назначают ретинол для профилактики его дефицита
2. **#пентоксифиллин** — 400 мг 2 раза в день 4–6 недель

Гипербарическая оксигенация и глюкокортикоиды при посттравматической боли после облучения

1. **гипербарическая оксигенация** — не менее 10 сеансов
2. **глюкокортикоиды** — #дексаметазон 8–20 мг в сутки 3–5 дней с постепенной отменой или #преднизолон в эквивалентной дозе

Вмешательства и операции

При неэффективности других методов выполняют имплантацию нейростимулятора прецентральной коры.

При постгерпетической невралгии в зоне надглазничного нерва применяют импульсную или термическую радиочастотную абляцию надглазничного нерва под контролем КТ после диагностической блокады.

При постгерпетической невралгии возможна имплантация системы периферической стимуляции ветвей после тестовой стимуляции.

При посттравматической боли выполняют имплантацию нейростимулятора ветвей тройничного нерва после тестовой стимуляции.

При неэффективности других методов у пациентов с посттравматической болью возможна тригеминальная нуклеотрактотомия; она сопряжена с риском неврологических осложнений.

4.9 Кластерная головная боль

Купирование приступа

Ингаляция 100% кислорода через маску (лучше с клапаном) **12 л/мин**, иногда 15 л/мин, в течение **20 минут**.

Применяют триптаны; предпочтительно золмитриптан 5–10 мг интраназально в противоположную ноздрю.

Спрей #лидокаина: 4 дозы в ноздрю на стороне боли в положении полулёжа под 45°, голова повёрнута **на 30–40°** в сторону боли; действует около 2 часов.

Трансназальная блокада крылонёбного ганглия: тампон с 10% #лидокаином в носовой ход; эффект **через 30–40 минут**, продолжительность **не менее 5 часов**.

Профилактическое лечение

Препаратом профилактики является #верапамил.

1. начальная доза: **240 мг** в сутки, повышение на 80 мг каждые 3–4 дня;
2. ЭКГ выполняют до начала лечения, а после достижения 480 мг — на каждые добавленные 160 мг;
3. дозу можно повышать до 960 мг под наблюдением кардиолога.

На время подбора верапамила или при эпизодической форме **до 8 недель** назначают #преднизолон 100 мг утром 5 дней с последующим снижением на 20 мг каждые 3 дня.

#Лития карбонат применяют в дозе 353–900 мг; целевой уровень лития — 0,6–0,8 ммоль/л (не выше 1,2 ммоль/л). Контролируют электролиты, функцию почек, ТТГ, анализ крови, ЭКГ.

Возможно назначение #мелатонина 10 мг.

Применяют также #топирамат с титрацией до 50–100 мг.

При тяжёлом течении до подбора лечения выполняют блокады большого затылочного нерва анестетиком с глюкокортикоидом или без него; эффект сохраняется 2–4 недели.

Фармакорезистентные формы

При фармакорезистентной эпизодической форме выполняют радиочастотную абляцию крылонёбного ганглия.

При фармакорезистентной хронической форме абляцию крылонёбного ганглия выполняют после положительной блокады.

Для хронической фармакорезистентной формы применяют также стимуляцию затылочных нервов.

Ещё один вариант при хронической фармакорезистентной форме — стимуляция крылонёбного ганглия.

4.10 Другие тригеминальные автономные цефалгии

Пароксизмальная гемикрания

При пароксизмальной гемикрании назначают #индометацин до 250 мг в сутки.

SUNCT и SUNA

При SUNCT применяют #ламотриджин с 50 мг в сутки (при SUNA он менее эффективен).

Другой вариант при SUNCT — #габапентин с 300 мг с повышением на 300 мг каждые 3 дня до 4200 мг.

При SUNA используют другие противоэпилептические средства.

При обострении SUNCT на время подбора лечения вводят #лидокаин внутривенно.

Гемикрания континуа

При гемикрании континуа назначают #индометацин 25 мг 3 раза в день 5–7 дней; при отсутствии эффекта — 50 мг, затем 75 мг 3 раза в день 2 недели.

4.11 Паралич Белла: лекарства

Глюкокортикоиды назначают **как можно раньше, лучше в первые 72 часа**, при любой тяжести: частота полного восстановления выше на 17%.

Дозы #преднизолона внутрь

1. **60 мг** в сутки 5 дней, затем снижение на 10 мг в сутки ещё 5 дней;
2. или **1 мг/кг** 7–10 дней; при V–VI степени и отсутствии противопоказаний возможно до **2 мг/кг** в сутки 10 дней;
3. суточную дозу принимают однократно утром в 6:00–8:00 после еды или в 2 приёма в первой половине дня.

Если лечение начато **в течение 3 дней** и тяжесть выше IV степени, предпочтительно однократное внутривенное введение #метилпреднизолона **500 мг** вместо перорального преднизолона.

Интратимпанальное введение глюкокортикоидов **до 10 дней** вместе с системной терапией может улучшить исход, но данных пока недостаточно.

Противовирусные средства применяют только вместе с глюкокортикоидами (в монотерапии они неэффективны), на ранней стадии при тяжёлой нейропатии и (или) подтверждённой вирусной инфекции: ацикловир 800 мг 5 раз в сутки или валацикловир 1000 мг 3 раза в сутки.

При синдроме Рамсея Ханта рано назначают глюкокортикоиды (#преднизолон или #метилпреднизолон) вместе с противовирусными средствами, **курс 7 дней**.

При подозрении на болезнь Лайма рано назначают антибиотики: доксициклин, амоксициллин или цефуроксим по инструкции.

При боли в мышцах применяют НПВП, предпочтительно ибупрофен.

Назначают комплекс витаминов группы В.

При неосложнённом лагофтальме невролог незамедлительно назначает увлажнение: днём искусственную слезу, на ночь декспантенол (гель); закапывание проводят до нескольких раз в день и ночью.

4.12 Нейропатия лицевого нерва: ботулинотерапия

В остром периоде токсин вводят в мышцы здоровой стороны при гипертонусе или высоком риске его развития (смещение средней линии ухудшает восстановление); в хроническом — в поражённую сторону при синкинезиях и в здоровую для достижения симметрии. Интервал между введениями в среднем 5 месяцев; метод эффективнее в сочетании с реабилитацией. Возможные нежелательные явления: гематома, избыточная слабость обработанной или соседних мышц (диплопия, нарушение речи).

При умеренном и выраженном гипертонусе мышц здоровой стороны вводят ботулинический токсин типа А в мышцы здоровой стороны, всего **до 50 ЕД**, в сочетании с ЛФК.

При гипертонусе поражённой стороны инъекции выполняют с двух сторон, всего **до 100 ЕД**, в сочетании с ЛФК.

При умеренном и выраженном постпаралитическом гемиспазме инъекции также выполняют с двух сторон, **до 100 ЕД**, в сочетании с ЛФК.

При поражении краевой нижнечелюстной ветви препарат вводят в мышцу, опускающую нижнюю губу, на здоровой стороне: 5 ЕД в одну точку или по 2 ЕД в 2 точки.

4.13 Нейропатия лицевого нерва: операции

Метод выбирают по сроку от дебюта, уровню, причине и тяжести поражения.

Виды хирургического лечения

1. **патогенетическое лечение идиопатической формы** — декомпрессия нерва в канале височной кости, которую проводят только при V–VI степени и разнице М-ответа более 90% с отсутствием потенциалов двигательных единиц
2. **симптоматическое лечение при любой форме** — реиннервирующая операция (**до 2 лет**, оптимально **до 18 месяцев**) или реконструктивно-пластическая; реиннервацию выполняют, если нет динамики в течение **6 месяцев**

Симптоматическое хирургическое лечение

Пациенты	Операция	Цель
тяжёлая нейропатия до 18 месяцев	реиннервирующие операции	восстановить функцию собственных мимических мышц
тяжёлая нейропатия более 18 месяцев	реконструктивно-пластические (аутотрансплантация мышцы)	заместить атрофированные мышцы
постпаралитический гемиспазм	селективная невротомия, нейрорафия, невролиз	естественная улыбка за счёт разобщения движений
лагофтальм	нейропластические, динамические и статические методы	восстановить или имитировать функцию круговой мышцы глаза

При параличе Белла тяжёлой степени выполняют невролиз и декомпрессию лабиринтного сегмента лицевого нерва.

Сроки

1. лучше **в первые 14 дней**, через среднюю черепную ямку;
2. возможно **до 3 месяцев**;
3. при положительной динамике не оперируют.

Перед декомпрессией выполняют КТ височной кости для определения ориентиров пирамиды и планирования доступа.

Перед декомпрессией обязательна тональная аудиометрия: риск потери слуха на стороне операции составляет **2–5%**.

При тяжёлой нейропатии **после 3 месяцев и до 2 лет** (лучше до 18 месяцев) показана реиннервирующая операция (нейрорафия).

При тяжёлой нейропатии **более 2 лет** выполняют реконструктивно-пластическую операцию: свободную пересадку или перемещение мышц.

При выраженном постпаралитическом гемиспазме применяют невролиз, нейрорафию, невротомию или миотомию; из-за риска слабости мышц требуется тщательный отбор пациентов.

Методы хирургического лечения при прозоплегии по виду и давности повреждения

1. **интракраниальное повреждение до 2 лет** — нейрорафия XII–VII «бок в конец» со вставкой из большого ушного нерва или «конец в конец» с челюстно-подъязычной или жевательной ветвью (С, 4)
2. **нет симметричных синхронных движений** — нейрорафия XII–VII «конец в конец» с икроножным нервом, в том числе по типу мионевротизации (С, 4)
3. **экстракраниальное повреждение с сохранением ствола и ветвей до 2 лет** — нейрорафия XII–VII «бок в конец» с большим ушным нервом, «конец в конец» с жевательной ветвью или анастомоз V–VII с челюстно-подъязычной ветвью (в КР — «СВ», 4)

Методы хирургического лечения при прозоплегии (продолжение)

1. **экстракраниальное без сохранения ствола и ветвей до 2 лет** — ревизия со вставками из большого ушного и (или) икроножного нерва или нейрорафия XII–VII, V–VII со вставками (С, 4)
2. **интракраниальное более 2 лет с атрофией** — пересадка или перемещение мышц с реиннервацией жевательной ветвью и кросс-пластикой (С, 4); если невозможно — статическая коррекция фасцией (С, 4) или нитями

Методы хирургического лечения при прозопарезе по виду повреждения

1. **интракраниальное повреждение** — нейрорафии XII–VII «бок в бок», V–VII «конец в бок», VII–VII «конец в бок» с икроножным нервом или с мионевротизацией (С, 4)
2. **экстракраниальное повреждение** — ревизия ствола и ветвей, нейрорафии, вставки, кросс-пластика (С, 4)

Методы хирургического лечения при прозопарезе: контрактуры, синкинезии, птоз тканей

1. **контрактуры здоровой стороны** — селективная миотомия или нейротомия на здоровой стороне с мониторингом нерва, нейрорафия VII–VII (С, 4)
2. **контрактуры и синкинезии поражённой стороны** — нейрорафия VII–VII, селективная нейротомия, миотомия (С, 4)
3. **птоз тканей** — статическая коррекция фасцией или круговая подтяжка лица (С, 4)

При паралитическом лагофтальме **более 2 лет** устраняют ретракцию верхнего века и лагофтальм: золотой грузик в верхнее веко, кожно-хрящевой лоскут с ушной раковины, кантопексия, блефарорафия.

4.14 Гемифациальный спазм

Лечением первой линии является ботулинический токсин типа А с двух сторон, всего до 100 ЕД, предпочтительно на ранних этапах.

Мишени

1. круговая мышца глаза;
2. щёчная мышца;
3. подкожная мышца шеи.

Улучшение у 76–100% в течение 7 дней, эффект **до 90 дней**, интервал **от 3 месяцев**.

При возврате спазма после васкулярной декомпрессии также применяют ботулинический токсин, до 100 ЕД.

Препараты при отсутствии показаний к операции, противопоказаниях к ней, отказе пациента или неэффективности ботулинотерапии

1. #карбамазепин 400–1200 мг в сутки;
2. #габапентин 600–1200 мг;
3. #клоназепам 0,5–4 мг, #диазепам и #лоразепам — в эквивалентных дозах;
4. #баклофен 15–80 мг;
5. #леветирацетам 500–1500 мг;
6. #зонисамид 150 мг 2 раза в сутки 6 недель.

Эффективность этих препаратов не доказана; часто возникают седация и утомляемость.

При первичном спазме с нейроваскулярным конфликтом на МРТ выполняют микроваскулярную декомпрессию корешка лицевого нерва; излечение в течение года **более 90%**.

Во время декомпрессии проводится интраоперационный мониторинг Lateral Spread Recording.

Если операция не показана, противопоказана, пациент отказался или другие методы неэффективны, выполняют радиохирургию лицевого нерва перед внутренним слуховым отверстием: 8 Гр однократно или 15 Гр за 5 фракций.

4.15 Лицевая миокимия

При первичной миокимии рекомендуются покой, ограничение кофеина, устранение провоцирующих факторов (курение, алкоголь); миокимия проходит за несколько дней или недель. При вторичной миокимии проводится лечение основного заболевания.

Если миокимия сохраняется **более 3 месяцев**, сначала исключают другие причины, затем вводят ботулинический токсин 5–20 ЕД в мышцу с гиперкинезом.

4.16 Невралгия языкоглоточного нерва

Как и при тригеминальной невралгии, применяют консервативный, малоинвазивный и хирургический подходы. Лечение начинают с монотерапии, препараты добавляют поочерёдно.

Медикаментозное лечение

#Карбамазепин назначают по правилам дозирования при тригеминальной невралгии, 100–2000 мг в сутки.

#Окскарбазепин начинают с 300 мг и постепенно повышают до 1200 мг в сутки.

#Габапентин дозируют по правилам при тригеминальной невралгии, 100–5000 мг в сутки.

Дополнительно вводят ботулинический токсин типа А по 1,25–5 ЕД внутрикожно в перикраниальные мышцы и мышцы шеи, всего 25–100 ЕД.

Малоинвазивные вмешательства

Выполняют импульсную радиочастотную абляцию языкоглоточного нерва под контролем КТ или УЗИ.

Применяют блокаду языкоглоточного нерва в проекции шиловидного отростка под контролем КТ или УЗИ.

Хирургическое лечение

При фармакорезистентной первичной невралгии выполняют микроваскулярную декомпрессию корешка в нейрохирургическом центре.

Если декомпрессия невозможна или пациент отказался, применяют радиохирургию корешка (предпочтительно «Гамма-нож»).

При невозможности декомпрессии возможна частичная сенсорная ризотомия.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Реабилитация при нейропатии лицевого нерва

Медицинская реабилитация в остром и хроническом периоде включает массаж лица, растяжение и расслабление, укрепление мышц лица и шеи, нервно-мышечное переобучение и биологическую обратную связь.

При тяжёлой нейропатии (V–VI степень) применяют лечение положением (пластырь, кинезиотейп), массаж и пассивные упражнения. При лёгкой и умеренной (до IV степени) показаны массаж и активные упражнения с дозированной симметричной нагрузкой. Пациенту объясняют: **избегать тепла, «грубого» массажа, электростимуляции, активной мимики** и упражнений с максимальной амплитудой.

При тяжёлой нейропатии на поражённую сторону накладывают кинезиотейп, чтобы не допустить перерастяжения мышц и восстановить симметрию.

При тяжёлой нейропатии назначают пассивные упражнения, при умеренной и лёгкой (IV степень и меньше) — активные с дозированным сокращением. **Активная ЛФК при тяжёлой нейропатии не рекомендуется**: здоровая сторона берёт на себя гиперфункцию и смещает среднюю линию.

Пациенту рекомендуют комплекс упражнений для самостоятельного выполнения.

Биологическую обратную связь проводят с помощью зеркала (или миографии).

При гипертонусе здоровой стороны или риске его развития в остром периоде показаны упражнения на растяжение и расслабление мышц здоровой стороны.

При гипертонусе и (или) синкинезиях на поражённой стороне растяжение и расслабление выполняют с двух сторон; синкинезии появляются **с 3-го месяца**.

Домашнюю самореабилитацию контролируют; обучают ей на первичном приёме невролога.

При неосложнённом лагофтальме днём на верхнее веко накладывают пластырь или кинезиотейп, а при эктропионе подтягивают нижнее веко; на ночь при несмыкании **более 4 мм** проводят окклюзию глаза.

При неосложнённом лагофтальме показаны упражнения для баланса круговой мышцы глаза и леватора верхнего века.

При изолированном поражении краевой нижнечелюстной ветви выполняют упражнения для мышцы, опускающей нижнюю губу, 2–3 раза в день перед зеркалом; при благоприятном прогнозе симметрия восстанавливается за 4–5 месяцев.

Дополнительно к стандартному лечению применяют иглорефлексотерапию; она эффективнее в остром периоде.

Форсированные упражнения **не рекомендуются**, так как укорачивают мышечные волокна и повышают риск синкинезий.

Электростимуляция мышц **не рекомендуется** по тем же причинам, что и форсированные упражнения.

Применяют гипербарическую оксигенацию.

Применяют лазерную физиотерапию (низко- и высокоинтенсивную) челюстно-лицевой области.

5.2 Диспансерное наблюдение

При сохранении симптомов нейропатии лицевого нерва или гемифациального спазма показано наблюдение невролога.

При сохранении лицевой миокимии показано наблюдение невролога.

5.3 Показания к госпитализации

Нейропатия лицевого нерва — экстренно

1. в первые **72 часа** — для внутривенного введения #метилпреднизолона в высокой дозе;
2. другие неврологические симптомы: слабость или онемение конечностей, головокружение, нарушение глотания;
3. ухудшение с нарушением сознания, лихорадкой, менингеальными симптомами;
4. декомпенсация давления или сахара, беременность.

Планово

1. операция.

Выписка

1. диагноз установлен;
2. состояние стабилизировано.

Тригеминальная невралгия — экстренно

1. впервые сильная боль в зоне глазничной ветви с вегетативными симптомами (отёк век, гиперемия склеры, потливость лба, изменение зрачка, слезотечение, ринорея или заложенность носа) — исключить патологию кавернозного синуса;
2. другие очаговые неврологические симптомы;
3. некупируемая боль.

Планово

1. малоинвазивные вмешательства и операции.

Выписка

1. диагноз установлен, боль уменьшилась, состояние стабильно.

Атипичная лицевая боль и автономные цефалгии — экстренно

1. нарушение сознания;
2. лихорадка и менингеальные симптомы;
3. нарастающая очаговая или общемозговая симптоматика;
4. некупируемая кластерная головная боль — для ингаляций кислорода.

Планово

1. нарастающая боль;
2. резистентная боль — ботулинотерапия или вмешательства (возможно в дневном стационаре).

Выписка

1. снижение интенсивности боли.

Тригеминальная нейропатическая боль — экстренно

1. подозрение на связь с Herpes zoster у пожилых, при иммунодефиците и онкологических заболеваниях.

Планово

1. вмешательства и операции.

Гемифациальный спазм, лицевая миокимия и другие черепные нервы

1. **гемифациальный спазм**: госпитализация плановая, для операции
2. **лицевая миокимия**: лечение амбулаторное
3. **другие черепные нервы**: экстренных показаний нет; плановая госпитализация показана для вмешательств и операций

5.4 Исход

Полное восстановление наблюдается от 61% при тотальной прозоплегии до 94% при более лёгком парезе.

Осмотр не всегда отражает истинную тяжесть: при V–VI степени ЭНМГ обязательна; асимметрия М-ответа **более 90%** хотя бы по одной ветви указывает на неблагоприятный прогноз. Гипертонус здоровой стороны развивается у 68,5% пациентов в первые 3 месяца и ограничивает восстановление.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Краниальные мононейропатии у взрослых»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	895_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Всероссийское общество неврологов; Союз реабилитологов России; Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии; Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии; Ассоциация интервенционного лечения боли
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки реконструктивно-пластической операции при нейропатии лицевого нерва расходятся: в таблице 21 и разделе 2.5 — после 18 месяцев, в рекомендации раздела 3.2.1 — после 2 лет.
- Гемифациальный спазм в разделе 1.5 назван «первичный (симптоматический)», а в разделе 1.2 первичный спазм — от сдавления сосудом, симптоматический — вторичный.
- В разделе 2.3 рекомендация об анализах при гемифациальном спазме адресована «всем пациентам с НЛН»; в разделе 2.5.3 (другие черепные нервы) рекомендации о психиатре и нейрохирурге говорят о тригеминальной невралгии.
- У одной рекомендации о реиннервирующей операции (раздел 3.2.1) уровень убедительности указан как «СВ».
- Код G52.2 (поражения блуждающего нерва) есть в каталоге рубрикатора, но не в разделе 1.4 КР.

Клинические рекомендации

Крапивница

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**L50** — Крапивница **L50.0** — Аллергическая крапивница **L50.1** — Идиопатическая крапивница **L50.2** — Крапивница, вызванная воздействием низкой или высокой температуры **L50.3** — Дерматографическая крапивница **L50.4** — Вибрационная крапивница **L50.5** — Холинергическая крапивница **L50.6** — Контактная крапивница **L50.8** — Другая крапивница **L50.9** — Крапивница неуточненная **T78.3** — Ангионевротический отек
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 19.07.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/264_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Крапивницей называют группу заболеваний, при которых развиваются волдыри, ангиоотёки или то и другое вместе. Острая крапивница длится **менее 6 недель**, хроническая — **более 6 недель**.
- Диагноз клинический: обратимые волдыри и (или) ангиоотёки. При острой крапивнице обследование не проводится, если нет указаний на провоцирующий фактор; при хронической — ограниченный обязательный объём.
- Основа лечения — неседативные антигистаминные препараты второго поколения, при хронической крапивнице — регулярно, а не по потребности. При недостаточном эффекте дозу повышают до четырёхкратной, затем добавляют омализумаб, затем #циклоспорин.
- При ангиоотёке гортани с угрозой жизни показана экстренная интубация трахеи или трахеостомия; если крапивница или ангиоотёк — проявление анафилаксии, помощь оказывается по рекомендациям «Анафилактический шок».
- Госпитализации подлежат пациенты с ангиоотёком гортани и риском асфиксии, тяжёлой острой крапивницей, анафилаксией, торпидным к амбулаторному лечению обострением.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

1. **крапивница** — группа заболеваний, характеризующихся развитием волдырей, ангиоотёков или того и другого вместе
2. **ангиоотёк** — диффузный отёк с захватом всей дермы и подкожной жировой клетчатки и (или) слизистой оболочки и подслизистого слоя

Состояния, при которых волдыри являются симптомом (кожные тесты, аутовоспалительные синдромы, анафилаксия, наследственный ангиоотёк), к крапивнице не относятся.

2.2 Этиология, патогенез и эпидемиология

Медиаторы активированных тучных клеток (гистамин, серотонин, фактор активации тромбоцитов, цитокины) вызывают вазодилатацию, повышение проницаемости капилляров и выход плазмы. Почти у половины пациентов с хронической крапивницей определяются IgG-аутоантитела к IgE (5–10%) и к FcεRI (35–40%). Дегрануляцию вызывают также комплемент, нейропептиды, тепло, холод, НПВП, контрастные средства, опиоиды.

Распространённость острой крапивницы — 20%, у детей — 2,1–6,7%. Хроническая спонтанная крапивница поражает 0,5–5% населения, женщины болеют чаще.

2.3 Классификация

Крапивницу классифицируют по продолжительности, типам и подтипам; у одного пациента возможны две и более формы. Индуцируемая крапивница может протекать хронически и включена в классификацию хронической.

1. **острая** — волдыри и (или) ангиоотёки в период **менее 6 недель**; каждый волдырь существует **не более 24 часов**
2. **хроническая** — волдыри ежедневно или почти ежедневно **более 6 недель**; спонтанная (идиопатическая) — самая частая разновидность

2.4 Клиническая картина

Признаки волдыря

1. центральный отёк разных размеров, почти всегда окружённый эритемой;
2. зуд, иногда жжение;
3. обратимость: волдырь исчезает бесследно **в течение 1–24 часов**.

Волдыри сначала бледно-розовые, при нарастании отёка, особенно у детей, могут становиться фарфорово-белыми. Сливаются в местах трения одеждой; на лице могут почти не выступать над кожей.

Признаки ангиоотёка

1. быстро развивающийся отёк глубоких слоёв дермы, подкожной клетчатки и подслизистого слоя;
2. чувство распирания и болезненности чаще, чем зуд;
3. возможное отсутствие эритемы; кожа бледная, плотная, ямка при надавливании не образуется;
4. разрешение **в срок до 72 часов**.

Поражаются ткани с рыхлой клетчаткой: веки, губы, щёки, слизистая оболочка полости рта, языка, гортани; при рецидивах нередко те же локализации.

1. **отёк слизистой оболочки носа** — чихание, затруднение носового дыхания
2. **губы и язык** — резкое асимметричное увеличение, нарушение речи
3. **гортань** — осиплость голоса вплоть до афонии из-за отёка голосовых складок, затем затруднение дыхания

Острая крапивница в большинстве случаев остаётся единственным эпизодом. Хроническая течёт волнообразно без прогрессирующего ухудшения: ремиссия в течение года наступает у 10–30%, за 3 года — у 30–50%, после 5 лет — у 40–70% пациентов; сопутствующий ангиоотёк связан с большей длительностью.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз крапивницы устанавливается по наличию обратимых волдырей и (или) ангиоотёков; лабораторное подтверждение требуется только для выявления причины. Обследование начинают с анамнеза, физикального обследования и основных анализов, исключающих тяжёлые системные заболевания.

3.2 Жалобы и анамнез. Физикальное обследование

Что уточняют

1. вид, размер, локализацию и длительность элементов, зуд, боль; наличие и локализацию ангиоотёков;
2. начало и длительность эпизода, цикличность появления элементов;
3. эффективность антигистаминных препаратов и предшествующего лечения;
4. связь с приёмом ацетилсалициловой кислоты, НПВП, ингибиторов АПФ, пищи, физическими стимулами, стрессом;
5. атопические заболевания, крапивницу в личном и семейном анамнезе, хронические заболевания, поездки, профессию и хобби.

Измеряют АД, ЧСС, температуру, оценивают периферические лимфатические узлы, печень, селезёнку, лёгкие, сердце, брюшную полость: это помогает выявить заболевания, связанные с крапивницей.

3.3 Лабораторные исследования

При острой крапивнице обследование не рекомендуется, кроме случаев указания в анамнезе на провоцирующий фактор. При хронической обследование проводится всем для выявления причины, в ограниченном обязательном объёме.

Обязательный объём при хронической крапивнице

1. общий анализ крови: воспалительная реакция, эозинофилы, базофилы;
2. СРБ;
3. общий IgE;
4. IgG-антитела к тиреопероксидазе.

По показаниям

1. биохимический анализ крови;
2. исследования на паразитарную инвазию, Helicobacter pylori и вирусные инфекции.

1. антинуклеарные антитела — при подозрении на системный аутоиммунный процесс;
2. C1-ингибитор и его функциональная активность — при изолированных ангиоотёках.

1. C3, C4, C1q и биопсия кожи — при подозрении на уртикарный васкулит;
2. внутрикожный тест с аутосывороткой — для выявления функциональных аутоантител.

Провокационные тесты при индуцированной крапивнице

1. холодовой и тепловой;
2. с давлением (замедленная крапивница от давления);
3. с ультрафиолетом и видимым светом (солнечная);
4. на дермографизм;
5. аквагенный;
6. с физической нагрузкой (холинергическая).

Антигистаминные препараты отменяют **за 48 часов** до тестов. Детям тесты не запрещены, но не стандартизованы.

3.4 Ларингоскопия

Показания к ларингоскопии при хронической крапивнице

1. подозрение на ангиоотёк гортани;
2. вовлечение ротоглотки;
3. отёк лица и губ без чётких данных за отёк гортани — индивидуально.

Выполняют фиброларингоскопию или видеоларингоскопию; исследование проводит оториноларинголог или другой специалист для дифференциальной диагностики и выбора вмешательства.

3.5 Оценка активности и консультации

1. **UAS7** — индекс активности крапивницы за 7 дней: число высыпаний и интенсивность зуда, оценка пациентом каждые 24 часа
2. **AAS** — оценка активности ангиоотёков
3. **UCT** — тест контроля крапивницы за последние 4 недели
4. **DLQI** — качество жизни, **с 16 лет**

У детей валидированных инструментов нет; чаще применяют UAS7.

При хронической крапивнице показана консультация аллерголога-иммунолога и (или) дерматовенеролога. Острую крапивницу и стандартные случаи хронической при достигнутом контроле может вести педиатр или терапевт.

3.6 Дифференциальная диагностика

Заболевания с уртикарными высыпаниями

1. **уртикарный васкулит** — волдыри сохраняются более 24 часов, пурпура, гиперпигментация, жжение и боль чаще зуда; диагноз — по биопсии
2. **пигментная крапивница (мастоцитоз)** — красно-коричневые пятна и папулы, симптом Унны — Дарье; чаще у детей
3. **аутовоспалительные синдромы (CAPS, синдром Шнитцлер)** — лихорадка, уртикарная сыпь, поражение суставов, повышение острофазовых маркеров
4. **другие** — буллёзный пемфигоид, многоформная эритема, Т-клеточная лимфома кожи, боррелиоз, фиксированная лекарственная сыпь, СКВ, синдром Свита

---

4. Лечение

4.1 Устранение причин

1. отменить или заменить подозреваемые лекарственные препараты (ингибиторы АПФ, НПВП);
2. лечить выявленные инфекционные и воспалительные процессы, паразитарную инвазию.

При доказанной пищевой аллергии исключают причинные продукты; длительные ограничительные диеты при хронической спонтанной крапивнице не рекомендуются.

При индуцированных формах избегают соответствующего триггера: перегревания, охлаждения, давления на кожу, прямого солнца (фотозащита SPF 50+).

4.2 Острая крапивница и ангиоотёк

Препаратами выбора являются неседативные антигистаминные средства второго поколения.

Седативные препараты первого поколения парентерально — только по особым показаниям (генерализованная крапивница при стабильной гемодинамике): клемастин **с 1 года** в/м, **с 18 лет** в/м или в/в; хлоропирамин **с 1 месяца** в/м. Детям **до 6 месяцев** коротким курсом — диметинден 0,1 мг/кг в сутки в 3 приёма.

При отсутствии эффекта антигистаминных препаратов назначают глюкокортикоиды минимальным курсом; постепенная отмена при коротком курсе не нужна.

1. взрослые: преднизолон внутрь 20–50 мг в сутки, **до 10 дней**;
2. дети: преднизолон 1–2 мг/кг в сутки, **3–7 суток**;
3. тяжёлый ангиоотёк у взрослых, требующий госпитализации: #метилпреднизолон 60–80 (125) мг внутривенно, затем внутрь 5–7 дней.

При жизнеугрожающем ангиоотёке гортани выполняется экстренная интубация трахеи или трахеостомия; показание определяют по результатам клинического обследования. Пациентам с индуцированной крапивницей, перенёсшим анафилаксию, необходимо иметь при себе противошоковый набор с раствором эпинефрина 0,1% 1,0 мл.

4.3 Хроническая крапивница: первая линия

Неседативные антигистаминные препараты второго поколения принимают регулярно, а не по потребности; при индуцированных формах — перед ожидаемым действием триггера.

Седативные препараты первого поколения без особых показаний не рекомендуются: седация, нарушение координации, холинолитические эффекты, тахифилаксия.

Стандартные дозы

1. дезлоратадин: 6–12 месяцев — 1 мг; 1–5 лет — 1,25 мг; 6–11 лет — 2,5 мг; с 12 лет — 5 мг 1 раз в сутки;
2. левоцетиризин: 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки; старше 6 лет — 5 мг 1 раз в сутки;
3. лоратадин: 2–12 лет — 5 мг (масса до 30 кг) или 10 мг; старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки;
4. цетиризин: 6–12 месяцев — 2,5 мг; 1–2 года — 2,5 мг 2 раза; 2–6 лет — 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз; старше 6 лет — 5–10 мг 1 раз в сутки;
5. старше 12 лет: фексофенадин 180 мг, эбастин 10–20 мг, рупатадин 10 мг, биластин 20 мг 1 раз в сутки.

Повышение дозы при неполном эффекте

1. взрослым — от двукратной до четырёхкратной; дальше четырёхкратной не увеличивают;
2. детям — с осторожностью **до двукратной**;
3. повышают дозу одного препарата, не комбинируя разные антигистаминные средства.

Повышение дозы не зарегистрировано, кроме эбастина — в 2 раза **с 15 лет**.

4.4 Вторая и третья линии

Омализумаб добавляют пациентам **с 12 лет** с хронической спонтанной крапивницей.

1. показание: симптомы сохраняются **более 2–4 недель** на увеличенной дозе антигистаминных препаратов или нестерпимы;
2. доза: 300 мг подкожно **1 раз в 4 недели**, курс **не менее 6 месяцев**;
3. при недостаточном ответе по решению врачебной комиссии — #омализумаб до 600 мг и (или) интервал 2 недели.

Если на фоне антигистаминных препаратов и омализумаба контроль не достигнут **за 6 месяцев** (или раньше при нестерпимых симптомах, либо при отсутствии омализумаба), добавляют #циклоспорин. Лечение проводят врачи с опытом иммуносупрессивной терапии, с постоянным контролем функции почек, печени и АД.

При тяжёлом обострении хронической крапивницы применяют короткий курс глюкокортикоидов в тех же дозах, что при острой крапивнице; длительные курсы не рекомендуются из-за побочных эффектов.

4.5 Беременность и лактация

У беременных и кормящих применяют тот же алгоритм с осторожностью и оценкой пользы и риска. Препаратами первой линии являются неседативные антигистаминные средства второго поколения: лоратадин с возможной экстраполяцией на цетиризин и левоцетиризин. Безопасность повышенных доз у беременных и кормящих не изучена.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика и диспансерное наблюдение

Профилактика обострений

1. устранение физических и иных триггеров: холод, тепло, нагрузка, ингибиторы АПФ, НПВП;
2. контроль активности по анкетам UAS7, UCT, AAS;
3. базисная терапия.

Вакцинация проводится по индивидуальному плану в период контроля заболевания, не в обострение.

Всех пациентов (законных представителей) обучают: причины, симптомы, обследование, лечение и контроль крапивницы, ведение дневника.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. тяжёлая острая крапивница и ангионевротический отёк гортани с риском асфиксии;
2. крапивница, сопровождающая анафилаксию;
3. тяжёлое обострение хронической крапивницы и ангиоотёк, торпидные к амбулаторному лечению.

Как правило, пациентов госпитализируют в аллергологическое, дерматовенерологическое, педиатрическое или терапевтическое отделение.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Крапивница»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 19.07.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	264_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Российское общество дерматовенерологов и косметологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации не выявлено.

Клинические рекомендации

Круп, эпиглоттит, постинтубационный отёк гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J05.0** — Острый обструктивный ларингит [круп] **J05.1** — Острый эпиглоттит **J38.4** — Отек гортани **J38.6** — Стеноз гортани
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/352_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Круп (острый обструктивный ларингит): воспаление гортани и подскладочного пространства с сужением просвета, как правило вирусной природы; болеют преимущественно дети **от 6 месяцев до 6 лет**. Эпиглоттит: острое бактериальное воспаление надгортанника (Haemophilus influenzae типа b), может быстро привести к асфиксии.
- Лечение крупа:
  1. всем пациентам: кортикостероиды (#дексаметазон однократно или будесонид ингаляционно);
  2. антибиотики и паровые ингаляции не рекомендуются;
  3. тяжёлый круп: ингаляция #эпинефрина;
  4. сатурация **92% и ниже**: оксигенотерапия;
  5. стеноз IV степени: интубация трахеи.
- Эпиглоттит:
  1. экстренная госпитализация в отделение с возможностью интубации;
  2. положение только сидя;
  3. ранняя интубация трахеи;
  4. антибиотик внутривенно всем пациентам;
  5. ротоглотку осматривают только в операционной в готовности к интубации;
  6. ингаляции, седативные средства и беспокойство ребёнка противопоказаны.
- Постэкстубационный отёк гортани:
  1. системные глюкокортикоиды внутривенно **не менее 48 часов**;
  2. нет улучшения **в течение часа**: реинтубация без прерывания лечения.
- Госпитализация при крупе:
  1. стеноз гортани II–III степени;
  2. невозможность адекватного лечения дома;
  3. прогрессирующее ухудшение.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. острый обструктивный ларингит (круп): воспаление гортани и тканей подскладочного пространства с сужением просвета гортани; прежние названия — «стенозирующий ларинготрахеит», «ложный круп»;
2. эпиглоттит: остро возникшее бактериальное воспаление надгортанника и окружающих тканей, может быстро привести к жизнеугрожающему нарушению проходимости дыхательных путей.

2.2 Этиология

Круп: наиболее частые возбудители — респираторные вирусы, причём до 80% случаев обусловлено вирусом парагриппа. Среди прочих возбудителей встречаются вирусы гриппа A и B, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы и другие. В крайне редких случаях причиной бывают бактерии, например Mycoplasma pneumoniae.

Постинтубационный отёк гортани: причиной является эндотрахеальная интубация, при которой нередко возникает поражение гортани от давления эндотрахеальной трубки. Оно проявляется отёком разной степени, изъязвлениями, грануляциями и ограничением подвижности голосовых складок, что приводит к сужению просвета в первые 24 часа после экстубации. У половины пациентов отёк требует реинтубации.

Эпиглоттит

В подавляющем большинстве случаев возбудителем является Haemophilus influenzae типа b (более 90%). В странах с массовой иммунизацией против гемофильной инфекции у вакцинированных детей эпиглоттит встречается редко и может быть вызван другими возбудителями, а эпиглоттит, обусловленный этим возбудителем, чаще встречается у взрослых. В редких случаях его вызывают пневмококк, стрептококки групп A и C, золотистый стафилококк, Moraxella catarrhalis и другие.

2.3 Степени стеноза гортани

Степени стеноза гортани по В. Ф. Ундрицу (1969)

Степень	Клинические проявления
I (стадия компенсации)	Осиплость, грубый навязчивый кашель, умеренная одышка
II (стадия неполной компенсации)	Осиплость, грубый навязчивый кашель, выраженная одышка, возбуждение, дыхание с участием вспомогательной мускулатуры, втяжение податливых мест грудной клетки, раздувание крыльев носа, цианоз носогубного треугольника, тахикардия
III (стадия декомпенсации)	Осиплость, грубый навязчивый кашель, беспокойство, страх, возможна апатия, резкая одышка с выраженным втяжением податливых мест грудной клетки, бледность, акроцианоз
IV (терминальная стадия, асфиксия)	Сознание отсутствует, резкая бледность и цианоз, гипотермия, возможны судороги, мидриаз, частое поверхностное дыхание, артериальная гипотензия, нитевидный пульс; предшествует остановке дыхания и сердца

Шкала тяжести крупа Westley

Признак	Баллы
Стридор	отсутствует: 0 при возбуждении: 1 в покое: 2
Втяжение уступчивых мест грудной клетки	отсутствует: 0 лёгкое: 1 умеренно выраженное: 2 резко выраженное: 3
Проходимость дыхательных путей	нормальная: 0 нарушена умеренно: 1 значительно снижена: 2
Цианоз	отсутствует: 0 при двигательной активности: 4 в покое: 5

Признак	Баллы
Сознание	без изменений: 0 нарушения сознания: 5

Оценка суммы баллов

1. лёгкий круп: **2 и менее**;
2. среднетяжёлый: **3–7**;
3. тяжёлый: **8 и более**;
4. угроза остановки дыхания: **12 и более**.

За рубежом используют также классификацию по степени тяжести: лёгкий, среднетяжёлый, тяжёлый и терминальный круп по лающему кашлю, стридору, втяжению межрёберий, возбуждению или сонливости и цианозу.

2.4 Клиническая картина

Круп

Начало

1. признаки ОРВИ: ринорея, першение в горле, кашель;
2. чаще невысокая температура;
3. перед развитием стеноза возникают осиплость и (или) сухой грубый кашель, затем лающий кашель и шумный вдох (стридор);
4. симптомы, как правило, появляются вечером, ночью или под утро.

При стенозе I степени стридор в покое отсутствует и возникает при беспокойстве или нагрузке; при II степени стридор слышен и в покое. Стеноз III степени требует экстренной помощи.

Более 2/3 обращаются со стенозом I степени, тяжёлый стеноз — менее чем у 1% детей; симптомы обычно купируются **за 48 часов**.

Постинтубационный отёк гортани: отёк начинается вскоре после интубации, а симптомы появляются после удаления трубки. Большинство пациентов предъявляют жалобы на лёгкие симптомы: боль в горле, дисфонию, затруднение глотания.

Появление стридора свидетельствует о клинически значимой обструкции верхних дыхательных путей; стридор и дыхательная недостаточность возникают при обструкции более половины просвета.

Клиническая картина может проявиться в первые минуты и часы после экстубации, однако описаны случаи отёка, потребовавшего реинтубации спустя **48–72 часа**. В среднем симптомы купируются **через 72 часа**, у большинства пациентов спонтанно **за 24–48 часов**.

Безопасного верхнего предела длительности интубации у детей нет.

Эпиглоттит: тяжёлая бактериальная инфекция.

1. острое начало с высокой температуры и нарушения общего состояния;
2. боль в горле, тризм, слюнотечение, поза «треножника», приоткрытый рот;
3. быстро нарастающий стридор, западение надгортанника в положении на спине;
4. типичного для крупа лающего кашля нет.

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. круп: диагноз клинический, как правило устанавливается на основании анамнеза и симптомов — осиплости голоса, лающего кашля, инспираторного стридора;
2. эпиглоттит: острое начало с высокой температуры и нарушения общего состояния; боль в горле, тризм, слюнотечение, поза «треножника», приоткрытый рот; быстрое развитие стридора, западение надгортанника в положении на спине; лающего кашля нет;
3. постинтубационный отёк: боль в горле, дисфония, затруднение глотания, стридор после экстубации; инструментально — УЗИ гортани у интубированных, у взрослых также тест на герметичность манжеты.

Ротоглотку ребёнка с подозрением на эпиглоттит осматривают только в операционной в полной готовности к интубации: высок риск рефлекторного спазма гортани и асфиксии.

При крупе и эпиглоттите уточняют вакцинацию против гемофильной, пневмококковой инфекции и дифтерии.

3.1 Осмотр и аускультация

Признаки респираторного дистресса

1. цианоз;
2. участие вспомогательной мускулатуры;
3. втяжение яремной ямки и межрёберных промежутков;
4. частота дыхания;
5. сатурация.

Аускультативно уточняют характер одышки: при крупе она инспираторная, а экспираторной или смешанной становится при сопутствующей бронхиальной обструкции или тяжёлом крупе.

3.2 Пульсоксиметрия

Показания

1. круп и эпиглоттит: оценка дыхательной недостаточности, необходимости кислорода, динамики.

3.3 Общий анализ крови и С-реактивный белок

Показания

1. круп: только при высокой лихорадке, когда нужно исключить бактериальную инфекцию; в стационаре общий анализ крови всем, СРБ по необходимости.

Показания

1. подозрение на эпиглоттит, высокая лихорадка: развёрнутый общий анализ крови, при необходимости СРБ.

Для эпиглоттита характерны лейкоцитоз более 15×10^9/л и повышенный СРБ. Анализы берут, только когда это безопасно, иногда лишь после интубации.

3.4 Посев с надгортанника и посев крови

Показания

1. эпиглоттит, селективно: этиологическая диагностика с определением чувствительности.

Берут после восстановления проходимости дыхательных путей; посев с надгортанника у неинтубированного пациента противопоказан.

3.5 Рентгенография мягких тканей шеи

При крупе рутинно не проводят: неспецифична и малоинформативна.

Показания

1. сомнительные случаи эпиглоттита со стёртой симптоматикой: боковая проекция.

Диагностические признаки

1. отёк надгортанника — симптом «большого пальца».

Любое исследование при подозрении на эпиглоттит может спровоцировать обструкцию дыхательных путей.

3.6 УЗИ гортани и фиброларингоскопия перед экстубацией

Показания

1. интубированные взрослые и дети, селективно: проходимость верхних дыхательных путей перед экстубацией.

Измеряют ширину воздушного столба на уровне складок до и после сдувания манжеты; её уменьшение предсказывает постэкстубационный стридор, точность метода окончательно не установлена.

Фиброларингоскопия перед экстубацией при наличии ресурсов — пациентам с факторами риска, прежде всего после трудной интубации или со стридором и дисфонией через 48–72 часа. Подсвязочное пространство не видно, а стенозы обычно подсвязочные.

Показания

1. взрослые перед экстубацией: тест на герметичность манжеты (утечка воздуха при сдутой манжете).

У детей прогностическая ценность низкая, широко не применяется.

3.7 Дифференциальная диагностика

Круп и эпиглоттит дифференцируют между собой и с другими причинами обструкции верхних дыхательных путей. Эпиглоттиту не свойственны катаральные явления, кашель и осиплость. Уточняют атопию, эпизоды бронхообструкции или стеноза, признаки гастроэзофагеального рефлюкса.

Круп и эпиглоттит: клинические различия

Признак	Круп	Эпиглоттит
Возраст	6 месяцев – 3 года	старше 3 лет
Развитие стридора	постепенное (24–72 ч)	быстрое (8–12 ч)
Симптомы	катаральный продром, грубый лающий кашель, осиплость, грубый инспираторный стридор, редко шум на выдохе; боли в горле нет или умеренная	умеренный ринит, несильный кашель, приглушённый, но не осиплый голос, умеренный стридор, усиливается лёжа на спине, низкий звук на выдохе; боль в горле; «опасные» признаки: гиперсаливация, тризм
Лихорадка и интоксикация	чаще субфебрилитет, интоксикации нет	температура выше 39 °C, выраженная интоксикация и недомогание
Рентгенография	сужение дыхательных путей	отёк надгортанника, симптом «большого пальца»

Дифференциальная диагностика крупа с клинически сходными состояниями

Заболевание	Наиболее частый возраст	Клинические проявления	Лабораторная и инструментальная диагностика
Круп	6 месяцев – 6 лет	острое начало, «лающий» кашель, стридор, осиплость голоса	не требуется
Паратонзиллярный абсцесс	6 месяцев – 3,5 года	боль в горле, лихорадка, гнусавый голос, речь по типу «картошка во рту»; смещение миндалины вниз и медиально, отклонение нёбного язычка, гиперемия и (или) налёт на миндалинах, возможен тризм	рентгенография мягких тканей шеи, КТ шеи, клинический анализ крови (лейкоцитоз)
Заглоточный (ретрофарингеальный) абсцесс	2–4 года	лихорадка, слюнотечение, дисфагия, боль при глотании, боль в шее; возможны тризм, отёк шеи, вынужденное положение: голова запрокинута назад и повёрнута в сторону абсцесса	рентгенография мягких тканей шеи, КТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием, клинический анализ крови (лейкоцитоз)
Ангиоотёк	в любом возрасте	отёк шеи и, возможно, лица, другие признаки аллергической (в том числе анафилактической) реакции; возникает после контакта с аллергеном или токсическим веществом	в дальнейшем аллергологическое обследование: кожные тесты или специфические иммуноглобулины E
Аспирация инородного тела	чаще до 3 лет	эпизод «поперхивания», острое затруднение дыхания, слюнотечение	рентгенография мягких тканей шеи, КТ шеи, трахеобронхоскопия
Химический и термический ожог верхних дыхательных путей	в любом возрасте	контакт с химическими веществами, тепловое воздействие	прямая ларингоскопия
Эпиглоттит	3–12 лет	острое нарушение глотания, боль при глотании, слюнотечение, высокая лихорадка, беспокойство, приглушённый голос	рентгенография мягких тканей шеи (утолщённый надгортанный хрящ), клинический анализ крови (лейкоцитоз)
Дифтерийный (истинный) круп	в любом возрасте	развивается медленнее, на фоне субфебрильной температуры (кроме токсической формы) и интоксикации; боль в шее и её отёк; налёты на миндалинах грязно-серого цвета, трудно отделяющиеся	посев на Corynebacterium diphtheriae, молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на возбудителя дифтерии, определение антител к дифтерийному токсину
Бактериальный трахеит	до 6 лет	высокая лихорадка, «лающий» кашель, нарастающие симптомы дыхательной недостаточности	клинический анализ крови (лейкоцитоз), рентгенография мягких тканей шеи (сужение просвета трахеи)

Заболевание	Наиболее частый возраст	Клинические проявления	Лабораторная и инструментальная диагностика
Гемангиома	до 6 месяцев	усиление стридора на фоне беспокойства	трахеобронхоскопия
Аномалии верхних дыхательных путей: трахеомаляция, ларингомаляция, расщелина гортани, стеноз подсвязочного пространства	с первых 6 месяцев жизни до 4,5 года	рецидивирующие эпизоды «лающего» кашля и стридора	трахеобронхоскопия
Новообразования	в любом возрасте	нарастающие изменения дыхания и голоса	рентгенография мягких тканей шеи в боковой проекции, КТ шеи
Увулит	в любом возрасте	отёк и эритема нёбного язычка; этиология бактериальная или аллергическая; может сопутствовать эпиглоттиту	при аллергической этиологии — в дальнейшем аллергологическое обследование

При некоторых болезнях гортани (врождённый стридор, подскладочная гемангиома или неоплазия, парезы, ларингомаляция) затруднение вдоха усиливается во время острой респираторной инфекции и имитирует острый стеноз.

Постэкстубационный стридор дифференцируют с

1. ларингоспазмом;
2. ангионевротическим отёком, анафилаксией;
3. инородным телом дыхательных путей;
4. послеоперационной гематомой со сдавлением дыхательных путей;
5. парезом голосовых складок после операций на шее;
6. апноэ сна.

---

4. Лечение

4.1 Круп

Антибиотики при крупе не назначают: неэффективны.

Всем пациентам с крупом: ингаляционный будесонид и (или) системные кортикостероиды (#дексаметазон, #преднизолон).

Обычно достаточно однократного введения; детям **старше 3 лет** предпочтителен приём внутрь, он так же эффективен, как парентеральный. Повторное введение, как правило, не нужно.

1. #дексаметазон: 0,15–0,6 мг/кг внутримышечно или внутривенно при любой степени стеноза; внутрь предпочтительно 0,15 мг/кг;
2. нет дексаметазона: #преднизолон в эквивалентной дозе (1 или 2 мг/кг соответствуют 0,15 и 0,6 мг/кг дексаметазона); после преднизолона выше риск повторных симптомов.

1. будесонид, суспензия через компрессорный или мэш-небулайзер: 2 мг в сутки однократно или по 1 мг дважды с интервалом 30 минут;
2. в 85% случаев (обычно при стенозе I степени) достаточно одной ингаляции; при необходимости ингаляции повторяют согласно инструкции.

Системные кортикостероиды, по ряду данных, эффективнее ингаляционных: беспокойство ребёнка мешает ингаляции.

Будесонид к #дексаметазону рутинно не добавляют: дополнительного эффекта нет.

Показания

1. тяжёлый круп или нет кортикостероидов: ингаляция #эпинефрина.

Доза

1. раствор 1:1000, 5 мл на ингаляцию независимо от возраста и массы.

Эффект быстрый, но нестойкий (**не более 2 часов**): в монотерапии не применяют. У детей препарат применяют вне инструкции, по решению врачебной комиссии с информированным согласием.

Исследований о необходимости и эффективности повторных ингаляций #эпинефрина не проводилось. Есть данные об эффективности более низких доз (ниже 0,5 мг/кг).

Показания

1. круп гриппозной этиологии: ингибиторы нейраминидазы — осельтамивир **с 1 года**, занамивир **с 5 лет**.

Других этиотропных средств против вирусов крупа нет.

Паровые ингаляции не рекомендуются: эффективность низкая.

При сатурации **92% и ниже** показана оксигенотерапия.

При стенозе гортани IV степени необходима неотложная интубация трахеи, при III степени её целесообразность рассматривают.

Жаропонижающая терапия

1. у детей допустимы только парацетамол или ибупрофен;
2. здоровым детям **от 3 месяцев**: при температуре **выше 39–39,5 °C**;
3. при лихорадке **38–38,5 °C**: детям **до 3 месяцев**, пациентам с хронической патологией, а также при дискомфорте, связанном с температурой.

Регулярный (курсовой) приём жаропонижающих нежелателен: повторную дозу вводят только после нового повышения температуры. Чередование парацетамола и ибупрофена или их комбинация не усиливает эффект. Ацетилсалициловую кислоту и нимесулид у детей с жаропонижающей целью не применяют; метамизол натрия крайне нежелателен из-за риска агранулоцитоза.

4.2 Эпиглоттит

Пациента не укладывают: только сидя, в том числе при транспортировке.

Ранняя интубация трахеи для профилактики внезапной асфиксии. Экстубация безопасна после нормализации температуры, прояснения сознания и стихания симптомов, обычно **через 24–48 часов**. В редких нетяжёлых случаях интубация может не понадобиться.

Ингаляции, снотворные и седативные средства категорически не рекомендуются; беспокойство пациента не провоцируют, поскольку высок риск рефлекторного ларингоспазма.

Всем пациентам с эпиглоттитом: системный антибиотик внутривенно.

Препараты и дозы

1. цефотаксим по инструкции или цефтриаксон: дети **от 15 дней до 12 лет** 20–80 мг/кг в сутки, оптимально 75 мг/кг в сутки; масса **более 50 кг и старше 12 лет** — дозы для взрослых;
2. в монотерапии или с антистафилококковым препаратом, например #ванкомицином 40 мг/кг в сутки;
3. неэффективность (вероятен S. aureus): клиндамицин 30 мг/кг в сутки внутривенно (по инструкции **с 3 лет**) или ванкомицин 40 мг/кг в сутки;
4. взрослые: те же препараты по инструкции, ванкомицин в средней дозе 40 мг/кг в сутки.

Длительность **7–10 дней**: сначала внутривенно, после купирования лихорадки, нормализации состояния и восстановления приёма жидкости через рот — внутрь: амоксициллин + клавулановая кислота, цефуроксим и другие цефалоспорины II–III поколения. Макролиды при эпиглоттите не применяют.

Эпиглоттит часто сопровождается бактериемией, что увеличивает длительность лечения. По зарубежным публикациям, доза цефтриаксона при эпиглоттите у детей составляет 50–100 мг/кг в сутки.

Сатурация **ниже 92%**: оксигенотерапия.

4.3 Постэкстубационный отёк гортани

Показания

1. симптомы постэкстубационного отёка у взрослых и детей: системные глюкокортикоиды внутривенно.

Дозы

1. дексаметазон: взрослым 5 мг на введение; детям в среднем 0,6 мг/кг в сутки;
2. метилпреднизолон: взрослым 20–40 мг;
3. #преднизолон: детям в среднем 1 мг/кг в сутки (от менее 1 до 2 мг/кг в сутки);
4. длительность **не менее 48 часов**.

Дополнительно, селективно

1. #эпинефрин ингаляционно: взрослым 1000 мкг в 5 мл 0,9% натрия хлорида; детям 1% раствор 0,25 мл в 2 мл 0,9% натрия хлорида или 0,5 мл, 2,5 мл, максимально 5 мл;
2. #будесонид небулайзером: взрослым и детям 1000 мкг 2 раза в сутки.

Возможны и более низкие дозы эпинефрина: после экстубации причина отёка устранена.

При отсутствии улучшения **в течение часа** консервативной терапии выполняют реинтубацию, не прерывая лечения.

Профилактика постэкстубационного отёка

Системные глюкокортикоиды с профилактической целью вводят селективно, пациентам с риском постэкстубационного отёка (факторы риска перечислены ниже), у взрослых — например, при отрицательном тесте на утечку воздуха из манжеты. Взрослым их вводят **не менее чем за 4 часа** до экстубации (по данным других авторов, **за 6–12 часов**).

Режим дозирования

1. взрослые: #метилпреднизолон 40 мг внутривенно **за 24 ч** до экстубации, или 40 мг 4 раза **за 24 ч**, или 20 мг 3 раза **за 12 ч**, или 40 мг **за 4 ч**; либо #дексаметазон 8 мг внутривенно **за 1 ч** или 5 мг 4 раза **за 48 ч** до экстубации;
2. дети: #дексаметазон 0,5 мг/кг на дозу каждые 6 часов **в течение 24 ч** до экстубации;
3. недоношенные новорождённые: 0,25 мг/кг, 4 дозы с интервалом 6 часов.

Наиболее эффективно введение **за 12–24 часа** до экстубации, далее при показаниях **24–48 часов** после неё; у детей раннее введение (**за 6–12 часов**) важнее дозы.

Выбор стратегии применения #дексаметазона учитывает

1. риск постэкстубационного отёка гортани;
2. факторы риска неудачи экстубации, в том числе слабость дыхательных мышц;
3. возможные побочные эффекты, в том числе желудочно-кишечное кровотечение и артериальную гипертензию;
4. время до плановой экстубации.

Факторы риска постинтубационного отёка гортани

Связанные с интубацией

1. трудная интубация в анамнезе;
2. большой размер трубки;
3. подвижность трубки;
4. интубация у детей **более недели**;
5. ИВЛ **48 часов** у детей **до 12 месяцев**;
6. экстренная интубация вне стационара.

После интубации

1. длительная интубация;
2. высокое давление в манжете;
3. возбуждение пациента;
4. самоэкстубация и реинтубация;
5. агрессивная аспирация слизи из трахеи.

Пациент и операция

1. операции на голове и шее, положение лёжа на животе при нейрохирургических операциях;
2. беременность, инфузионная терапия;
3. повреждения шеи и дыхательных путей, ингаляционные повреждения и ожоги;
4. низкий балл по шкале Глазго, лечение без седации;
5. женский пол, индекс массы тела более 26,5, гастроэзофагеальный рефлюкс, узкая гортань;
6. малый гестационный возраст, низкая масса тела при рождении, детский возраст.

4.4 Стеноз гортани вследствие отёка и хирургическое лечение

При стенозе гортани у пациентов любого возраста проводят консервативную дестенозирующую терапию: парентерально вводят глюкокортикоиды и петлевые диуретики.

При асфиксии и невозможности интубации у ребёнка с крупом и у пациента с эпиглоттитом выполняют трахеотомию с временной трахеостомой или коникотомию. В неосложнённых случаях хирургическое лечение не требуется.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Круп: дети с суммой баллов по шкале Westley **1–2**, как правило, не нуждаются в госпитализации; эффект ингаляции будесонида или инъекции #дексаметазона дома или амбулаторно позволяет обойтись без неё.

Показания к госпитализации

1. стеноз гортани II–III степени;
2. невозможность адекватной терапии дома;
3. прогрессирующее ухудшение состояния.

Госпитализация проводится в инфекционный стационар или боксированное отделение. Стационарную помощь оказывает врач-педиатр или врач-инфекционист, при необходимости — врач-оториноларинголог, по показаниям — врач-анестезиолог-реаниматолог. Выписка после купирования стеноза, нормализации температуры и сатурации; в среднем **1–2 дня**.

Родителей детей с рецидивирующим крупом обучают и составляют план действий: при симптомах нового эпизода — ингаляция будесонида или #дексаметазон (#преднизолон) внутримышечно.

Эпиглоттит: обязательная экстренная госпитализация, обычно бригадой скорой помощи, в отделение с интенсивной терапией и возможностью интубации.

Любые болезненные или неприятные пациенту манипуляции — инъекции, инфузии, иногда даже ингаляции — могут вызвать асфиксию. В стационаре в среднем **3–5 дней**. Стационарную помощь оказывает врач-педиатр (врач-терапевт) или врач-инфекционист, при необходимости — врач-оториноларинголог, по показаниям — врач-анестезиолог-реаниматолог.

Выписка

1. купирование стеноза;
2. нормальная температура и сатурация;
3. самостоятельный приём пищи и жидкости, аппетит.

5.2 Профилактика

Круп

1. гигиена: мытьё рук после контакта с больным, маски, обработка поверхностей и инструментов, изоляция заболевших детей, проветривание;
2. вакцинация от сезонного гриппа всем детям без противопоказаний.

Исследований о снижении частоты крупа у вакцинированных от гриппа детей нет. Поскольку круп может развиваться на фоне гриппа, от вакцинации ожидают положительного эффекта в профилактике крупа, вызванного вирусами гриппа.

Эпиглоттит: вакцинация против гемофильной инфекции всем детям без противопоказаний. Диспансерное наблюдение при крупе и эпиглоттите не требуется; медицинская реабилитация не требуется.

Исход крупа при своевременной диагностике и адекватном лечении благоприятный; при поздней диагностике со стенозом III–IV степени и невозможности интубации или трахеостомии возможна смерть от асфиксии. Прогноз эпиглоттита всегда серьёзный, своевременное лечение обеспечивает выздоровление.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый обструктивный ларингит [круп], эпиглоттит, постинтубационный отёк гортани»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 14.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	352_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; МАКМАХ; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Мальформация кровеносных сосудов головы и шеи

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D10** — Доброкачественное новообразование рта и глотки **D18** — Гемангиома и лимфангиома любой локализации **Q25.8** — Другие врожденные аномалии крупных артерий **Q25.9** — Врожденная аномалия крупных артерий неуточненная **Q26.8** — Другие врожденные аномалии крупных вен **Q26.9** — Порок развития крупной вены неуточненный **Q27** — Другие врожденные аномалии [пороки развития] системы периферических сосудов **Q28.8** — Другие уточненные врожденные аномалии системы кровообращения **Q28.9** — Врожденная аномалия системы кровообращения неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/848_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Мальформацией кровеносных сосудов (МКС) называют аномалию развития капилляров, вен, артерий или их сочетания, возникающую вследствие дизэмбриогенеза кровеносной системы. Мальформация растёт пропорционально росту пациента и, в отличие от инфантильной гемангиомы, не инволютирует.
- Диагноз клинический: его устанавливают по анамнезу, осмотру, физикальному обследованию и данным лучевых и функциональных методов.
- Всем пациентам выполняют дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области; по пиковой систолической скорости в нидусе различают МКС «быстрого потока» (**20 см/с и выше**) и «низкого потока» (**менее 20 см/с**).
- Грудному ребёнку при первом обращении лечение не проводят: **от 2 недель до 1 месяца** наблюдают темп роста и дифференцируют мальформацию от инфантильной гемангиомы. Консервативное лечение проводится только при гемангиоме.
- **Лечение по форме мальформации**
  1. **артериовенозная** — удаление после эндоваскулярной окклюзии, которую выполняют **за 1–2 суток до операции**
  2. **венозная** — удаление с пластикой (1–2 анатомические области), склерозирование, комбинированные методы, радиочастотная термоабляция
  3. **капиллярная** — лазерное излучение и этапные сеансы фототерапии
- **Не рекомендуется**
  1. перевязка наружной сонной артерии как самостоятельный метод лечения;
  2. эндоваскулярная эмболизация при питающих сосудах из бассейна внутренней сонной артерии;
  3. радиочастотная термоабляция при поверхностном расположении мальформации.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение и формы

1. **капиллярная мальформация** — низкоскоростное нарушение капиллярной сети кожи и слизистых оболочек; диаметр сосудов 100–2000 мкм при норме 10–100 мкм
2. **артериовенозная мальформация** — высокоскоростная патология с прямыми сообщениями артерий и вен в обход микроциркуляторного русла (нидус)
3. **венозная мальформация** — гемодинамически неактивная слабопотоковая мальформация собирательной части сосудистой сети; наиболее распространённая сосудистая аномалия

1. **гиперплазия кровеносных сосудов (инфантильная гемангиома)** — реактивный опухолевидный рост тканей на основе пролиферации эндотелия
2. **нидус** — центральный очаг артериовенозной мальформации: прямые сообщения сосудов разного диаметра или сеть мельчайших капилляров

2.2 Этиология и эпидемиология

Этиология до конца не изучена; для ряда ангиодисплазий доказаны генные мутации. Критическим периодом возникновения является **4–20-я неделя внутриутробного развития**. Как правило, мальформации выявляют в первые недели и месяцы жизни, затем они растут пропорционально росту пациента; бурный рост наблюдается у девушек в пубертатном периоде, при беременности, после травмы, инфекции, стресса.

МКС головы и шеи составляют 5–14% всех сосудистых поражений; около 80% мальформаций головы и шеи составляют капиллярные мальформации. Венозные мальформации головы и шеи по распространённости уступают только поражению нижних конечностей.

2.3 Классификация

Классификация ISSVA (2018)

1. простые: капиллярные, венозные, артериовенозные мальформации, артериовенозные фистулы;
2. комбинированные (КВМ, КЛМ, КАВМ, ЛВМ, КЛВМ и другие);
3. аномалии магистральных сосудов;
4. сосудистые мальформации, ассоциированные с другими аномалиями (синдромы Клиппеля — Треноне, Паркса Вебера, Штурге — Вебера, Маффуччи и другие).

Классификация В. В. Рогинского и соавт. (2021)

1. **по клиническому течению** — стабильные, прогрессирующие
2. **по поражённому сегменту** — капиллярно-венозные, артериальные, венозные, смешанные, артериовенозные свищи
3. **по скорости кровотока** — низкоскоростные, высокоскоростные

2.4 Клиническая картина

Проявления

1. изменение цвета кожи и слизистых оболочек от красно-розового до тёмно-вишнёвого — основное проявление;
2. реже увеличение объёма тканей, видимая деформация с асимметрией лица;
3. поражение костей лицевого и мозгового черепа, чаще челюстей, изолированное или вместе с мягкими тканями.

Поражение растёт синхронно с ростом пациента.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз МКС клинический. Его верифицируют по анамнезу жизни (у детей с акушерским анамнезом матери) и заболевания с выяснением МКС у ближайших родственников, по визуальному осмотру, физикальному обследованию, лучевым и функциональным методам.

3.2 Жалобы и анамнез

При первых признаках сосудистой патологии челюстно-лицевой области и шеи пациенту любого возраста необходима консультация челюстно-лицевого хирурга.

Что уточняют у пациента или родителей

1. изменение цвета кожи и слизистых оболочек в динамике;
2. нарушение конфигурации мягких тканей;
3. эпизоды кровотечения.

3.3 Физикальное обследование

Что оценивают

1. размер, объём и форму образования;
2. деформацию контуров лица и шеи, эстетические параметры;
3. функцию носового дыхания, жевания, окклюзию;
4. окраску кожи и слизистых оболочек;
5. пульсацию мягких тканей при пальпации.

Диагностические признаки

1. **венозный компонент** — багрово-синюшный оттенок, увеличение объёма мягких тканей; флебэктаз указывает на венозную мальформацию
2. **артериальный компонент** — ало-красная окраска, гиперемия, местное повышение температуры, пульсация, систолический шум при аускультации
3. **капиллярная или ранняя КМ-АВМ** — ярко-красная окраска кожи различной интенсивности

Мультидисциплинарная команда при обширных поражениях и сложных анатомических областях

1. детский хирург, нейрохирург;
2. оториноларинголог, офтальмолог;
3. специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, сердечно-сосудистый хирург;
4. врач ультразвуковой диагностики, генетик.

План лечения команда составляет после диагностических исследований. При деформации лицевого скелета или дизокклюзии необходима консультация ортодонта.

3.4 Лабораторные исследования

Взрослым с обширными МКС перед операцией оценивают гемостаз: общий анализ крови и коагулограмму (протромбиновое, тромбиновое, АЧТВ, МНО).

3.5 Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области

Выполняется всем пациентам: оценивают структуру образования, локализацию, тип и скорость кровотока. По пиковой систолической скорости в нидусе мальформацию относят к «быстрому потоку» при **20 см/с и выше** и к «низкому потоку» при **менее 20 см/с**.

3.6 Капилляроскопия

Детям с поверхностными проявлениями капилляроскопия позволяет визуализировать микрососуды и отличить мальформацию от инфантильной гемангиомы.

3.7 КТ-ангиография

Показания

1. визуализация ангиоархитектоники головы и шеи у взрослых;
2. подозрение на внутрикостное поражение (ВМ, АВМ, смешанная мальформация) в сложных анатомических областях.

Плотность в нидусе **более 70 HU** соответствует высоковаскуляризированной мальформации, **менее 70 HU** — низковаскуляризированной. Детям **до 5–6 лет** исследование проводят под наркозом.

3.8 МРТ мягких тканей с контрастированием

При обширных венозных, артериовенозных и смешанных мальформациях в сложных анатомо-топографических областях МРТ уточняет распространённость, локализацию и топографию поражения. Детям **до 5–6 лет** МРТ проводят под наркозом.

При поражении половины лица и эпилептических приступах МРТ головного мозга исключает или подтверждает синдром Штурге — Вебера — Краббе.

3.9 Эндоскопия верхних дыхательных путей и пищевода

Всем пациентам с нарушениями дыхания и глотания выполняют видеоларингоскопию, видеориноскопию, эзофагогастроскопию, чтобы выявить поражение гортаноглотки, крылочелюстного пространства или шеи.

3.10 Селективная ангиография

При мальформациях с интенсивным кровотоком перед операцией выполняют селективную ангиографию: она выявляет «питающие сосуды» артериовенозной мальформации.

3.11 Диагностическая пункция

При подозрении на изолированную костную мальформацию выполняют пункцию кисты полости рта под контролем УЗИ: изолированные поражения челюстей могут имитировать кисты, а получение крови под давлением позволяет предположить МКС.

---

4. Лечение

4.1 Тактика

При первом обращении родителей с грудным ребёнком лечение не проводят: **от 2 недель до 1 месяца** фиксируют темп увеличения очага и дифференцируют мальформацию от гемангиомы. Мальформация растёт за счёт гипертрофии, а не пролиферации эндотелия, и не инволютирует; консервативное лечение проводится только при гемангиоме.

Лечение дифференцированное, по форме мальформации; выбор метода зависит от её размеров, формы и локализации.

Рациональные методы

1. хирургическое лечение;
2. импульсная фототерапия;
3. радиочастотная и лазерная абляция;
4. эндоваскулярная эмболизация сосудов артериовенозной мальформации;
5. комбинация методов.

4.2 Артериовенозная мальформация

Взрослым с АВМ выполняют удаление мальформации с предварительной эндоваскулярной окклюзией её сосудов **за 1–2 суток до операции**.

Эмболизация снижает частоту осложнений и интраоперационную кровопотерю, облегчает идентификацию структур. Без последующей операции она ведёт к образованию коллатералей и прогрессированию, а при отсроченной операции её эффект заметно уменьшается.

При локализации АВМ в функционально или эстетически значимой зоне выполняют частичное иссечение, а остаточные патологические ткани обрабатывают одним из методов термического воздействия.

4.3 Венозная мальформация

Хирургическое лечение по распространённости

1. **1–2 анатомические области** — одноэтапное удаление с пластикой раны местными тканями
2. **более 2 областей** — поэтапное иссечение или комбинированное лечение: склерозирование и иссечение, перевязка афферентных сосудов и склерозирование, иссечение и пластика мышцей
3. **2 и более области у взрослых** — дефект после резекции устраняют свободным реваскуляризированным лоскутом

Склерозирование применяют как самостоятельный метод или в комбинации с удалением. Наиболее эффективна пенная композиция: 15 мг #блеомицина и 4 мл 3% раствора #лауромакрогола 400 с введением воздуха по методу Тессари; манипуляцию выполняют под контролем УЗИ. Склерозанты применяются вне инструкции.

Склерозирование разрушает эндотелий с последующим воспалением, тромботической окклюзией, склерозом и уменьшением размера поражения. Взрослым также применяют комбинированную деструкцию прошиванием, склерозированием и компрессией: она уменьшает симптом венозного наполнения и интраоперационную кровопотерю.

При обширной венозной мальформации в сложной анатомической зоне с поражением глубоких слоёв выполняют радиочастотную термоабляцию под УЗ-контролем, чрескожно, чрезслизисто или открыто, как монолечение или в комбинации. При поверхностном расположении РЧТА не рекомендуется из-за риска термического ожога кожи.

4.4 Капиллярная мальформация

При обширных капиллярных мальформациях применяют лазерное излучение, наиболее эффективен импульсный лазер на красителе; воздействие проводят в несколько этапов. Всем пациентам с капиллярными мальформациями проводят этапные сеансы фототерапии кожи, у детей чаще под масочным наркозом.

При обширной мальформации, поражающей поверхностные слои, выполняют лазерную абляцию (неодимовый или гольмиевый лазер). После радиочастотной термоабляции или лазерной абляции носят давящую повязку **не менее 10 дней**.

4.5 Что не рекомендуется

Перевязка наружной сонной артерии как самостоятельный метод не рекомендуется при всех видах МКС: она сопряжена с высоким хирургическим риском, увеличивает кровоток на противоположной стороне и активирует образование коллатералей.

Эндоваскулярная эмболизация не рекомендуется при питающих сосудах из бассейна внутренней сонной артерии из-за риска миграции эмболов и инсульта. При венозных мальформациях эмболизация нецелесообразна и невозможна.

4.6 Послеоперационное кровотечение

Приёмы остановки кровотечения

1. тампонирование;
2. прошивание;
3. наложение давящей повязки;
4. склерозирующая терапия;
5. закрытая или открытая лазерная абляция.

4.7 Медицинская реабилитация

Принципы реабилитации

1. комплексная оценка поражения и программа реабилитации;
2. план диагностических и лечебных мероприятий;
3. мультидисциплинарная организация помощи;
4. контроль эффективности в процессе и по окончании курса.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Специфической профилактики нет. При подозрении на патологию при пренатальном УЗИ необходимы рациональное ведение беременности, консультация челюстно-лицевого хирурга после рождения, а при синдромальном варианте — консультация генетика.

Контроль после завершения лечения

1. осмотр челюстно-лицевого хирурга **через 6 и 12 месяцев**;
2. дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области **через 6 и 12 месяцев**;
3. МРТ мягких тканей головы и (или) шеи **через 12 месяцев**;
4. при внутрикостном поражении КТ лицевого отдела черепа **через 6 и 12 месяцев**.

Операции выполняют в круглосуточном стационаре челюстно-лицевые хирурги; госпитализация плановая.

Показания к госпитализации

1. инструментальные исследования под наркозом;
2. удаление очагов мальформации и устранение деформации после предыдущих этапов лечения.

Критерии выписки

1. выполнены запланированные лечебно-диагностические мероприятия;
2. полное или частичное удаление образования с улучшением анатомо-функционального состояния;
3. нет послеоперационных осложнений и ухудшения соматического состояния;
4. необходимость перевода в другое учреждение или требование пациента (законного представителя).

Факторы, ухудшающие результаты лечения

1. несоблюдение рекомендаций лечащего врача;
2. инфекционные осложнения;
3. несогласованная тактика специалистов на этапах лечения;
4. несоблюдение ограничений двигательной активности и физических нагрузок после вмешательств.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Мальформация кровеносных сосудов головы и шеи»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 18.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	848_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации не выявлено.

Клинические рекомендации

Мастоидит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H70** — Мастоидит и родственные состояния
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.09.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/311_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Мастоидит представляет собой деструктивное воспаление слизистой оболочки, надкостницы и костной основы ячеистой структуры сосцевидного отростка. При остром мастоидите изменения существуют **не более 1 месяца**, при хроническом (латентном) **более 1 месяца**.
- Критерии диагноза:
  1. боль в ухе и заушной области, головная боль, недомогание, лихорадка;
  2. острый или хронический гнойный средний отит либо травма височной кости в анамнезе;
  3. оттопыренность ушной раковины, гиперемия и пастозность заушной области, болезненность при пальпации и перкуссии сосцевидного отростка;
  4. нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода при отоскопии;
  5. нарушение пневматизации среднего уха и костная деструкция по данным компьютерной томографии (КТ) височной кости.
- Каждый пациент с мастоидитом, независимо от этиологии и стадии процесса, подлежит экстренной госпитализации в оториноларингологический стационар.
- Антибактериальную терапию начинают незамедлительно после установления диагноза, не дожидаясь результатов посева, препараты вводят парентерально:
  1. амоксициллин + клавулановая кислота;
  2. цефотаксим;
  3. цефтриаксон.
- Хирургическое лечение выполняют в экстренном порядке:
  1. первый этап при целой барабанной перепонке: парацентез или шунтирование и дренирование барабанной полости;
  2. второй этап при отсутствии положительной динамики **в течение 48–72 часов**: антромастоидотомия;
  3. при осложнениях (субпериостальный абсцесс или абсцесс шеи, внутричерепные осложнения, отогенный сепсис) антромастоидотомию выполняют без ожидания эффекта парацентеза.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Мастоидитом называют деструктивное воспаление слизистой оболочки, надкостницы и костной основы ячеистой структуры сосцевидного отростка. Первичный мастоидит развивается без предшествующего среднего отита, вторичный является осложнением среднего отита.

Антритом (отоантритом) называют деструктивное воспаление слизистой оболочки, надкостницы и костной ткани пещеры сосцевидного отростка, осложняющее острый средний отит у новорождённых и детей грудного возраста.

2.2 Классификация

Мастоидит классифицируют по преимущественной локализации воспалительного процесса в отростке (варианты приведены в разделе «Атипичные формы») и по клиническому течению:

1. Острый мастоидит: воспалительно-деструктивные изменения в ячеистой структуре сосцевидного отростка существуют **не более 1 месяца**.
2. Хронический (латентный) мастоидит: изменения сохраняются **более 1 месяца** и чаще связаны с хроническим гнойным средним отитом или затянувшимся острым средним отитом.

2.3 Клиническая картина

Общие симптомы

1. ухудшение общего состояния;
2. повышение температуры тела;
3. у детей вялость, сонливость, капризность, снижение аппетита.

Местные симптомы

1. нарастающая боль в ухе с иррадиацией в висок и затылок;
2. усиление гноетечения из уха (при блоке входа в пещеру может отсутствовать);
3. болезненность при надавливании на сосцевидный отросток;
4. оттопыренность ушной раковины;
5. гиперемия и пастозность заушной области;
6. нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода;
7. снижение слуха.

Лабораторные изменения

1. лейкоцитоз;
2. выраженное повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ);
3. нарастание С-реактивного белка (СРБ).

Лабораторные изменения неспецифичны для мастоидита, но дополняют клиническую картину.

2.4 Жалобы и анамнез

Жалобы

1. повышение температуры тела, ухудшение общего состояния;
2. снижение слуха;
3. головная боль;
4. боль в ухе и заушной области;
5. оттопыренность ушной раковины, припухлость и покраснение кожи за ухом;
6. у детей вялость, сонливость, капризность, снижение аппетита.

Анамнез

1. острый или хронический гнойный средний отит либо травма височной кости.

При хроническом мастоидите общее состояние может не страдать: беспокоят интермиттирующие спонтанные боли, особенно ночью, возможно снижение слуха.

2.5 Физикальное обследование

Отоскопия

1. сужение наружного слухового прохода за счёт нависания задневерхней стенки, гиперемия кожи нависающей части;
2. гиперемия, инфильтрация и выбухание барабанной перепонки;
3. при перфорации профузное гноетечение и пульсирующий рефлекс; при блоке входа в пещеру гноетечения может не быть.

Заушная область

1. пастозность мягких тканей и гиперемия кожи над сосцевидным отростком;
2. сглаженность складки у места прикрепления ушной раковины;
3. оттопыренность ушной раковины.

Следует оценить симметричность лица и функцию мимических мышц: при остром мастоидите возможен парез лицевого нерва.

2.6 Атипичные формы

Зигоматицит: отёк мягких тканей в проекции скулового отростка с распространением на щёку и веко.

Петрозит проявляется триадой Градениго:

1. ретроорбитальная боль (раздражение первой ветви тройничного нерва);
2. диплопия вследствие пареза отводящего нерва на стороне поражения;
3. симптомы воспаления среднего уха.

Мастоидит Бецольда проявляется кривошеей в больную сторону, отёком кожи и болезненностью по ходу грудино-ключично-сосцевидной, двубрюшной, ремённой мышц и длиннейшей мышцы головы.

При мастоидите Орлеанского вокруг места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы формируется инфильтрат: гной прорывается на наружную поверхность верхушки отростка без образования абсцесса. Повороты головы болезненны, но кривошеи нет, а надавливание на инфильтрат не усиливает гноетечение из уха.

Мастоидит Чителли: поражение угловых ячеек сосцевидного отростка с тромбозом сигмовидного синуса. Повороты головы болезненны, пальпация заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы вызывает боль, верхушка отростка при пальпации свободна.

При мастоидите Муре гной с верхушки сосцевидного отростка прорывается в ткани шеи и парафарингеальное пространство. Характерны дисфония, ощущение инородного тела в глотке, припухлость в переднем отделе боковой поверхности шеи, резкая болезненность при надавливании на грудино-ключично-сосцевидную мышцу под верхушкой отростка; при фарингоскопии выявляется инфильтрат или выбухание боковой и задней стенок глотки.

2.7 Этиология

При вторичном мастоидите инфекция проникает в ячейки сосцевидного отростка преимущественно отогенным путём при остром или хроническом гнойном среднем отите.

Возбудители, как правило, те же, что при остром гнойном среднем отите

1. преобладают Streptococcus pneumoniae и Streptococcus pyogenes;
2. обнаруживают также Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Fusobacterium necrophorum, Staphylococcus aureus и другие.

Факторы риска вторичного мастоидита

1. возраст до двух лет;
2. рецидивирующий острый средний отит;
3. неполная пневматизация сосцевидного отростка;
4. сопутствующие заболевания, снижающие иммунитет.

Первичный мастоидит имеет травматическое (удары, ушибы, переломы и трещины костей черепа, огнестрельные ранения) или гематогенное происхождение (септикопиемия, переход гнойного процесса из лимфатических узлов области сосцевидного отростка). Изолированное поражение сосцевидного отростка возможно при специфических инфекциях: туберкулёзе, инфекционных гранулёмах.

Ведущее звено патогенеза вторичного мастоидита заключается в недостаточном дренировании гнойного очага в среднем ухе. Ему способствуют запоздалое дренирование барабанной полости при задержке спонтанной перфорации или парацентеза при остром среднем отите, высокое расположение и малый размер перфорации при хроническом гнойном среднем отите, а также разобщение ячеек, антрума и барабанной полости отёчной утолщённой слизистой оболочкой.

Чаще всего костная деструкция формируется в проекции площадки сосцевидного отростка, и в заушной области образуется субпериостальный абсцесс, реже в области задней костной стенки наружного слухового прохода с отслойкой кожи и образованием свища. Деструкция чешуи височной кости приводит к сквамиту, вовлечение пирамиды к петрозиту. Распространение процесса к средней или задней черепной ямке ведёт к тяжёлым внутричерепным осложнениям: менингиту, абсцессам мозга и мозжечка, синустромбозу, сепсису.

2.8 Стадии

Экссудативная стадия продолжается первые 7–10 дней заболевания. Отёк слизистой оболочки разобщает ячейки с пещерой и пещеру с барабанной полостью, ячейки заполняются серозно-гнойным или гнойным экссудатом, образуя множество замкнутых эмпием. На КТ перегородки между завуалированными ячейками ещё различимы.

Пролиферативно-альтеративная стадия (истинный мастоидит) формируется обычно на 7–10-й день заболевания, у детей раньше. Грануляции и расплавление кости разрушают перегородки между ячейками, и образуются полости различной величины, заполненные гноем и грануляциями, или одна большая полость.

У детей плохой аэрации среднего уха и затруднению оттока способствуют частое нарушение носового дыхания, широкие короткие прямые слуховые трубы, эмбриональная миксоидная ткань в барабанной полости и высокое расположение сосцевидной пещеры, поэтому антрит возникает уже на ранней стадии острого среднего отита, особенно у новорождённых. Решающее значение имеют реактивность организма, инфекционные заболевания, недоношенность, перинатальная патология, гипо- и паратрофия, эндокринные заболевания.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

1. жалобы на боль в ухе и заушной области, головную боль, недомогание, повышение температуры тела;
2. острый или хронический гнойный средний отит либо травма височной кости в анамнезе;
3. оттопыренность ушной раковины, гиперемия и пастозность заушной области, болезненность при пальпации и перкуссии сосцевидного отростка;
4. нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода при отоскопии;
5. нарушение пневматизации структур среднего уха и костная деструкция по данным КТ височной кости.

3.2 Осмотр оториноларинголога

Первичный осмотр оториноларинголога при симптомах мастоидита нужен для постановки диагноза и определения тактики лечения.

3.3 Компьютерная томография височной кости

Выполняется всем пациентам с подозрением на мастоидит.

Диагностические признаки

1. нарушение пневматизации структур среднего уха;
2. костно-деструктивные изменения.

При отсутствии технической возможности КТ допустима рентгенография височной кости в проекциях Майера и Шюллера.

Уровни приведены для детей; для взрослых УУР С, УДД 4.

Показания к КТ с внутривенным болюсным контрастированием

1. подозрение на внутричерепные осложнения.

3.4 Общий (клинический) анализ крови и С-реактивный белок

Выполняют всем пациентам для оценки общего состояния и выраженности воспаления.

Диагностические признаки

1. нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево;
2. повышение СОЭ;
3. умеренная анемия;
4. повышение СРБ.

3.5 Микробиологическое исследование отделяемого из уха

Посев на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антимикробным препаратам.

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: выбор антибактериальной терапии.

3.6 Исследование слуха

Камертональное исследование и (или) речевая аудиометрия.

Показания

1. пациенты старше 7 лет с подозрением на мастоидит: диагностика нарушения слуха.

3.7 Консультация невролога

Показана всем пациентам с симптомами мастоидита для исключения осложнений.

---

4. Лечение

Консервативное лечение начинают незамедлительно после постановки диагноза. Цели лечения:

1. эрадикация возбудителя;
2. ограничение воспаления пределами височной кости;
3. уменьшение субъективных и объективных симптомов;
4. предупреждение стойкого снижения слуха.

4.1 Системная антибактериальная терапия

Всем пациентам назначают один из препаратов, не дожидаясь результатов посева; у взрослых и детей препараты вводят парентерально:

1. амоксициллин + клавулановая кислота;
2. цефотаксим;
3. цефтриаксон.

Препараты резерва

1. ванкомицин: при выделении метициллинорезистентного золотистого стафилококка (MRSA), стрептококков, резистентных к пенициллинам, при непереносимости бета-лактамных антибиотиков или отсутствии ответа на другие препараты;
2. #меропенем (детям): при выделении синегнойной палочки или штаммов, устойчивых к пенициллинам и другим бета-лактамам.

Пометка off-label (в КР — знак #) обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.

4.2 Режим дозирования антибактериальных препаратов

Препарат	Пациенты	Доза, путь и кратность введения
Амоксициллин + клавулановая кислота	Взрослые и дети старше 12 лет или с массой тела 40 кг и более	1 г (по амоксициллину) внутривенно 3 раза в сутки
Амоксициллин + клавулановая кислота	Дети от 3 месяцев до 12 лет с массой тела менее 40 кг	25 мг/кг (по амоксициллину) внутривенно 3–4 раза в сутки, 5–14 дней
Цефотаксим	Взрослые и дети старше 12 лет с массой тела 50 кг и более	1–2 г внутривенно или внутримышечно каждые 12 часов; доза зависит от тяжести инфекции, чувствительности возбудителя и состояния пациента
Цефотаксим	Дети до 12 лет с массой тела до 50 кг	100–150 мг/кг/сут внутривенно или внутримышечно в 2–4 введения, 7–10 дней
Цефотаксим	Новорождённые	50 мг/кг/сут внутривенно или внутримышечно в 2–4 введения
Цефтриаксон	Взрослые и дети старше 12 лет с массой тела более 50 кг	1–2 г каждые 24 часа
Цефтриаксон	Дети до 12 лет с массой тела менее 50 кг	20–80 мг/кг/сут 1 раз в сутки
Цефтриаксон	Новорождённые (до 14 дней)	20–50 мг/кг/сут внутривенно или внутримышечно, 7–14 дней
Ванкомицин	Взрослые и дети старше 12 лет	2 г/сут внутривенно капельно: по 0,5 г каждые 6 часов или по 1 г каждые 12 часов. Скорость введения не более 10 мг/мин, продолжительность инфузии не менее 60 минут; максимальная разовая доза 1 г, суточная 2 г
Ванкомицин	Дети от 1 месяца до 12 лет	10 мг/кг внутривенно каждые 6 часов, инфузия не менее 60 минут; суточная доза 40 мг/кг
#Меропенем	Дети	60 мг/кг/сут внутривенно в 3 введения каждые 8 часов

> Длительность курса в рекомендации указана только для части групп: амоксициллин + клавулановая кислота 5–14 дней, цефотаксим у детей до 12 лет 7–10 дней, цефтриаксон 7–14 дней (указано после дозы для новорождённых). Для остальных групп срок в тексте не приведён.

4.3 Местная терапия

Ушные капли

Показания к ушным каплям с противомикробными препаратами

1. перфорация барабанной перепонки;
2. послеоперационный период: введение через парацентезное отверстие или тимпаностомический шунт.

Препараты

1. офлоксацин взрослым и детям **старше 15 лет**: по 5 капель 2 раза в сутки, 10 дней;
2. рифамицин детям: по 3 капли 3 раза в сутки, 7 дней.

Для офлоксацина у взрослых УДД 4.

Назальные деконгестанты

Для восстановления функции слуховой трубы всем пациентам назначают назальные деконгестанты (оксиметазолин, ксилометазолин) **не дольше 7 дней**. У детей их применяют с особой осторожностью.

Уровни приведены для детей; для взрослых УДД 4.

Препарат	Возраст	Доза и кратность
Оксиметазолин 0,01%	до 4 недель	по 1 капле в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Оксиметазолин 0,01%	с 5-й недели до 1 года	по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Оксиметазолин 0,025%	от 1 года до 6 лет	по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Оксиметазолин 0,05%	взрослые и дети старше 6 лет	по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Ксилометазолин 0,05%	от 2 до 6 лет	по 1–2 капли в каждый носовой ход 1–3 раза в сутки
Ксилометазолин 0,1%	взрослые и дети старше 6 лет	по 2–3 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки

4.4 Симптоматическая терапия

При боли и (или) лихорадке, в том числе после операции, применяют парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП):

1. ибупрофен;
2. диклофенак;
3. кеторолак;
4. кетопрофен;
5. лорноксикам;
6. декскетопрофен.

Для лорноксикама и диклофенака у взрослых УУР В, УДД 2.

Обезболивание у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол в/в (когда внутривенное введение клинически оправдано или другие пути невозможны)	при массе тела более 50 кг 1 г, инфузия в течение 15 минут	не менее 4 ч	4 г	5–7 сут
Диклофенак	75 мг в/м (в КР «75 мл»)	12–24 ч	150 мг	2 сут
Кеторолак	30 мг в/в, в/м	8 ч	60 мг при массе тела менее 50 кг, 90 мг при массе более 50 кг	2 сут

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Кетопрофен	100 мг в/в, в/м	12–24 ч	200 мг	не более 2 сут
Лорноксикам	8 мг в/в, в/м	12 ч	16 мг	минимально эффективная доза минимально возможным курсом
Декскетопрофен	50 мг в/в, в/м	8–12 ч	150 мг	2 сут

Обезболивание у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол в/в (когда внутривенное введение клинически оправдано или другие пути невозможны)	инфузия в течение 15 минут до 4 раз в сутки: 10–50 кг 15 мг/кг; менее 10 кг 7,5 мг/кг; более 50 кг 1000 мг	4 ч	более 33 до 50 кг: не более 60 мг/кг, но не более 3 г; более 10 до 33 кг: не более 60 мг/кг, но не более 2 г; 10 кг и менее: не более 30 мг/кг; более 50 кг: 4 г	5–7 сут
Парацетамол внутрь	таблетки: от 12 лет 0,5–1 г; 9–11 лет 0,5 г; 6–8 лет 250 мг. Суспензия: от 3 месяцев до 12 лет 10–15 мг/кг до 4 раз в сутки	6 ч	от 12 лет 4 г; до 12 лет менее 60 мг/кг	3 сут
Парацетамол ректально	от 12 лет 0,5 г; до 12 лет 10–15 мг/кг	6 ч	от 12 лет 4 г; до 12 лет менее 60 мг/кг	3 сут
Ибупрофен внутрь	таблетки: от 12 лет 200 мг. Суспензия: 3–6 месяцев (5–7,6 кг) 50 мг до 3 раз в сутки; 6–12 месяцев (7,7–9 кг) 50 мг до 3–4 раз в сутки; 1–3 года (10–16 кг) 100 мг; 4–6 лет (17–20 кг) 150 мг; 7–9 лет (21–30 кг) 200 мг; 10–12 лет (31–40 кг) 300 мг, до 3 раз в сутки	8 ч	от 12 лет 1 г; 10–12 лет 900 мг; 7–9 лет 600 мг; 4–6 лет 450 мг; 1–3 года 300 мг; 6–12 месяцев 200 мг; 3–6 месяцев 150 мг	3 сут
Ибупрофен ректально	3–9 месяцев (6–8 кг) 60 мг; 9–24 месяца 60 мг	3–9 месяцев 8 ч; 9–24 месяца 6 ч	3–9 месяцев 180 мг; 9–24 месяца 240 мг	не более 3 сут
Кетопрофен в/в, в/м	с 15 лет 100 мг	12–24 ч	200 мг	не более 2 сут
Кетопрофен, гранулы для раствора внутрь	старше 6 до 14 лет 40 мг; 14–18 лет 80 мг	8 ч	6–14 лет 120 мг; старше 14 лет 200 мг	в КР не указана

4.5 Хирургическое лечение

Мастоидит и антрит требуют экстренного хирургического лечения, цель которого состоит в скорейшем обеспечении оттока экссудата из полостей среднего уха и предотвращении распространения процесса за пределы сосцевидного отростка.

4.6 Первый этап: парацентез или шунтирование барабанной полости

Показания

1. мастоидит при целой барабанной перепонке;
2. спонтанная перфорация недостаточного размера.

Это первый этап лечения неосложнённого острого мастоидита и антрита.

Предпочтительно установить тимпаностомический шунт, если для этого есть условия: перфорация не закрывается быстро, облегчаются введение ушных капель и отток отделяемого. При отсутствии положительной динамики **в течение 48–72 часов** переходят ко второму этапу.

4.7 Второй этап: антромастоидотомия или антродренаж (антротомия)

Показания

1. отсутствие эффекта от консервативного лечения и парацентеза или шунтирования **в течение 48–72 часов**;
2. субпериостальный абсцесс или абсцесс шеи;
3. признаки перехода инфекции на мозговые оболочки и другие внутричерепные осложнения;
4. отогенный сепсис;
5. вялотекущий процесс в сосцевидном отростке **более месяца** с рентгенологической картиной разрушения его тканей и жалобами пациента.

Антромастоидотомия: условия и объём вмешательства

1. комбинированный эндотрахеальный наркоз, желательно под контролем операционного микроскопа;
2. дети раннего возраста: вскрытие сосцевидного отростка ограничивается антральной клеткой;
3. дети **старше года** и взрослые: обязательна ревизия всей клеточной системы отростка;
4. после вскрытия антрума и окружающих клеток проверяют проходимость входа в пещеру.

Разрез мягких тканей ведут сверху вниз до верхушки сосцевидного отростка, отступив 5 мм от линии прикрепления ушной раковины; послойное рассечение позволяет выполнять гемостаз по ходу операции. Трепанацию проводят в пределах треугольника Шипо, антрум находят в глубине и кпереди, в проекции треугольника Траутмана. Ограничиваться вскрытием антрума не следует: при любой форме мастоидита необходима ревизия клеточной системы отростка с удалением всех патологически изменённых тканей и костных осколков, после чего полость промывают.

4.8 Послеоперационное ведение

1. При субпериостальном абсцессе или ожидаемом продолжении воспаления заушную рану полностью не ушивают: накладывают один-два шва в верхнем и нижнем углах и ведут рану открытым способом.
2. В остальных случаях в антрум устанавливают силиконовую дренажную трубку и рану ушивают полностью.
3. Перевязки выполняют ежедневно.
4. Дренажную трубку удаляют **на 5–7-е сутки**.
5. Открытую рану ушивают после полного очищения послеоперационной полости.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Все пациенты с мастоидитом, независимо от этиологии и стадии процесса, подлежат экстренной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профилю «оториноларингология».

Критерии выписки

1. нормализация общего состояния: отсутствие лихорадки и признаков интоксикации;
2. нормализация показателей общего и биохимического анализов крови;
3. отсутствие выделений из уха.

5.2 Медицинская реабилитация

Контрольное исследование слуха **через 1 месяц** после выздоровления всем перенёсшим мастоидит:

1. тональная аудиометрия пациентам **старше 7 лет**;
2. игровая аудиометрия детям **от 3 до 7 лет**;
3. регистрация вызванной отоакустической эмиссии детям **младше 3 лет**.

При снижении слуха пациента направляют к сурдологу-оториноларингологу.

5.3 Профилактика

1. профилактика острого среднего отита, заболеваний носа, околоносовых пазух и лимфоглоточного кольца;
2. квалифицированное лечение хронического среднего отита;
3. своевременное хирургическое лечение на среднем ухе, в полости носа, околоносовых пазухах, носоглотке и глотке.

Диспансерное наблюдение после мастоидита не требуется.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Мастоидит»
Версия	2-я, год утверждения 2026, опубликована в рубрикаторе 04.09.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2029 года
Код в рубрикаторе	311_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность антибактериальной терапии приведена не для всех групп пациентов: для амоксициллина + клавулановой кислоты и цефтриаксона срок указан один раз в конце фразы, для цефотаксима только у детей до 12 лет.
- Границы массы тела для цефтриаксона заданы как «более 50 кг» и «менее 50 кг»; пациенты с массой ровно 50 кг формально не охвачены.
- Алгоритм действий врача (Приложение Б) заканчивается этапом «Диспансерное наблюдение» после выздоровления, а в разделе 5 сказано, что диспансерное наблюдение после мастоидита не требуется.

- Приложение А3.1: разовая доза диклофенака записана как «75 мл в/м», по смыслу 75 мг. Сверяйте с инструкцией препарата.

Клинические рекомендации

Медуллярный рак щитовидной железы

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C73** — Злокачественное новообразование щитовидной железы
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 08.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов; Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Ассоциации эндокринных хирургов; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/332_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Медуллярный рак щитовидной железы — опухоль из секретирующих кальцитонин парафолликулярных С-клеток нейроэктодермального происхождения; составляет около 4–6% рака щитовидной железы, в 20–25% случаев входит в синдром МЭН2.
- Кальцитонин крови — высокочувствительный и специфичный маркер: при уровне **более 100 пг/мл** вероятность медуллярного рака приближается к 100%. Исследование выполняется на первичном этапе у всех пациентов с узловым образованием щитовидной железы.
- При резектабельном процессе показаны тиреоидэктомия и лимфодиссекция VI уровня; при доказанных метастазах в боковом лимфоколлекторе дополнительно — лимфодиссекция II–V уровней. До операции обязательно исключают феохромоцитому.
- Местно-распространённые формы проявляются дисфагией и нарушением фонации; при инвазии в пищевод, трахею, гортань объём операции решается индивидуально. Профилактическая тиреоидэктомия у носителей мутации позволяет избежать центральной лимфодиссекции, связанной с риском повреждения возвратных гортанных нервов.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Медуллярный рак щитовидной железы — опухоль из секретирующих кальцитонин парафолликулярных С-клеток щитовидной железы, которые происходят из нейроэктодермы, т. е. эмбриональной закладки, отличающейся от мезодермального происхождения А- и В-клеток.

2.2 Этиология и эпидемиология

Медуллярный рак при синдроме МЭН2 обусловлен мутацией в гене RET; заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу. Выделяют синдром Сиппла (МЭН2А) и синдром Горлина (МЭН2Б); наиболее агрессивное течение наблюдается при МЭН2Б. При спорадическом раке соматические мутации RET описаны в 25–40% случаев.

Медуллярный рак составляет около 4–6% всех случаев рака щитовидной железы; в 20–25% случаев его выявляют при синдроме МЭН2, в остальных он спорадический.

2.3 Классификация

Этиологическая классификация

1. спорадический медуллярный рак;
2. генетически детерминированный: синдром Сиппла (МЭН2А), в том числе семейный медуллярный рак;
3. синдром Горлина (МЭН2Б).

Группировка медуллярного рака по стадиям (TNM, 8-е изд.)

Стадия	Сочетание T, N, M
I	T1 N0 M0
II	T2–T3 N0 M0
III	T1–T3 N1a M0
IVA	T4a любое N M0; T1–T3 N1b M0
IVB	T4b любое N M0

Стадия	Сочетание T, N, M
IVC	любое T, любое N, M1

2.4 Клиническая картина

Локализованный медуллярный рак обычно не имеет специфической клинической картины и проявляется узловым образованием щитовидной железы.

1. **местно-распространённые формы** — дисфагия, нарушение фонации, синдром сдавления верхней полой вены
2. **распространённые формы** — диарея и синдром Кушинга из-за гиперсекреции гормонально-активных пептидов
3. **метастазы в кости** — боли в костях, патологические переломы

1. **синдром МЭН2А** — медуллярный рак, феохромоцитома, гиперпаратиреоз, реже болезнь Гиршпрунга и лихеноидный кожный амилоидоз
2. **синдром МЭН2Б** — медуллярный рак, феохромоцитома, марфаноподобный хабитус, множественные невромы губ, языка, конъюнктивы, ганглионейроматоз ЖКТ

Спорадический рак развивается чаще между 40 и 60 годами. У 70% с пальпируемым узлом имеются регионарные метастазы, у 10% — отдалённые.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

1. **до операции** — высокий уровень кальцитонина в крови, цитологическая картина рака щитовидной железы, высокий уровень кальцитонина в смыве из пункционной иглы
2. **после операции** — подтверждение при гистологическом и иммуногистохимическом исследовании

3.2 Жалобы и анамнез

Факторы риска медуллярного рака

1. семейный или личный анамнез рака щитовидной железы, феохромоцитомы;
2. дисфагия, дисфония;
3. увеличение шейных лимфатических узлов.

3.3 Физикальное обследование

При осмотре обращают внимание

1. изменение контуров шеи, узловое образование, увеличение регионарных лимфатических узлов;
2. изменение голоса;
3. симптомы гормональной продукции: гиперкортицизм, диарея;
4. проявления синдромов МЭН2: при МЭН2Б — марфаноподобная внешность, утолщение губ, образования на языке.

3.4 Лабораторные исследования

Кальцитонин крови исследуется у пациентов с узловым образованием, феохромоцитомой и другими признаками синдрома МЭН2. При уровне **более 100 пг/мл** вероятность медуллярного рака приближается к 100%; при 50–100 пг/мл — 25–81%, при 20–50 пг/мл — 8,3–26%.

Кальцитонин оценивают с учётом пола, возраста и методики: у мужчин он выше, чем у женщин, у детей **до 3 лет** — выше, чем у старших детей и взрослых.

ТАБ показана всем пациентам с подозрением на медуллярный рак; при умеренно повышенном кальцитонине (**менее 100 пг/мл**) цитологию дополняют определением кальцитонина в смыве из пункционной иглы, что повышает выявляемость до 98%.

Всем пациентам с медуллярным раком выполняется молекулярно-генетическое исследование мутаций RET в крови: оно отличает спорадические случаи от наследственных и определяет обследование родственников. При герминальной мутации исключают феохромоцитому, при МЭН2А — первичный гиперпаратиреоз.

3.5 Инструментальные исследования

Всем пациентам выполняют УЗИ щитовидной и паращитовидных желёз и лимфатических узлов шеи. Шкала TIRADS менее чувствительна при медуллярном раке: у 20–25% пациентов узел выглядит доброкачественным.

КТ шеи, грудной и брюшной полостей или МРТ брюшной полости с контрастированием выполняют при метастазах в регионарных узлах (N1) или кальцитонине **более 400 пг/мл** — для исключения отдалённых метастазов.

Перед операцией обязательно обследование для исключения феохромоцитомы: операция при недиагностированной феохромоцитоме ассоциирована с высоким риском фатальных событий.

---

4. Лечение

4.1 Хирургическое лечение

1. **резектабельный локорегионарный процесс** — тиреоидэктомия и лимфодиссекция VI уровня, вне зависимости от отдалённых метастазов (кроме симптоматических и жизнеугрожающих)
2. **доказанные метастазы в боковом лимфоколлекторе** — дополнительно лимфодиссекция II–V уровней
3. **инвазия в пищевод, трахею, гортань** — объём операции решается индивидуально с учётом риска осложнений и прогноза

Завершающая тиреоидэктомия с лимфодиссекцией VI уровня после гемитиреоидэктомии

1. мультицентрический рост опухоли;
2. положительный край резекции;
3. повышенный послеоперационный кальцитонин;
4. герминальная мутация RET или семейный анамнез МЭН2.

После тиреоидэктомии проводится заместительная терапия левотироксином натрия.

4.2 Системная терапия

Системная терапия показана при нерезектабельном и/или метастатическом раке с симптомами, жизнеугрожающим состоянием или прогрессированием по критериям RECIST; изолированное повышение кальцитонина и РЭА без подтверждённых метастазов основанием не является. При мутации RET назначают селективный ингибитор селперкатиниб.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

При герминальной мутации RET у больного обследуют всех родственников первой линии на наличие мутации. Профилактическая тиреоидэктомия у носителей без клинических проявлений позволяет предотвратить метастазирование и избежать центральной лимфодиссекции, связанной с риском гипопаратиреоза и повреждения возвратных гортанных нервов.

Сроки профилактической тиреоидэктомии по риску мутации RET

1. **высочайший риск (M918T)** — как можно раньше, **в течение 1-го года жизни**
2. **высокий риск (C634X, A883F)** — **в 5-летнем возрасте** или раньше при повышении кальцитонина; при кальцитонине **более 40 пг/мл** — с лимфодиссекцией
3. **умеренный риск** — ежегодное обследование **с 5 лет**, операция при повышении кальцитонина или выявлении опухоли

5.2 Диспансерное наблюдение

Кальцитонин и РЭА исследуют **через 2–3 месяца** после операции, затем **1 раз в 6–12 месяцев**. Критерий биохимической ремиссии — базальный кальцитонин **менее 10 пг/мл**.

1. **кальцитонин не нормализовался, но менее 150 пг/мл** — УЗИ шеи для выявления структурного рецидива
2. **кальцитонин более 150 пг/мл** — УЗИ шеи, КТ грудной полости, сцинтиграфия костей, МРТ печени или ПЭТ-КТ для поиска метастазов

5.3 Показания к госпитализации

Экстренная или неотложная госпитализация

1. осложнения онкологического заболевания;
2. осложнения лечения.

Плановая госпитализация

1. сложные интервенционные диагностические вмешательства;
2. специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в стационаре.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Медуллярный рак щитовидной железы»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	332_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Российская ассоциация эндокринологов и др.
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.

Клинические рекомендации

Менингококковая инфекция у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**A39** — Менингококковая инфекция
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.01.2026, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1020_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Менингококковая инфекция — острая антропонозная болезнь с воздушно-капельным путём передачи Neisseria meningitidis: интоксикация, поражение слизистой оболочки носоглотки и возможная генерализация в виде менингококкемии и/или гнойного менингита с характерной геморрагической сыпью.
- Менингококковый назофарингит клинически не специфичен: затруднение носового дыхания, скудные выделения из носа, гиперемия и отёк задней стенки глотки. Этиологический диагноз устанавливается по исследованию слизи с задней стенки глотки на менингококк.
- Больные и пациенты с подозрением на генерализованную форму подлежат обязательной экстренной госпитализации в инфекционный стационар с ОРИТ; антибиотик внутривенно вводится **не позднее 1 часа** после поступления.
- **Оториноларингологу**
  1. осмотр оториноларинголога показан всем пациентам с генерализованной формой: возможен назофарингит, при менингите — сенсоневральная тугоухость;
  2. серьёзным осложнением менингита является гнойный лабиринтит и кохлеарный неврит;
  3. дексаметазон при менингите с отёком мозга снижает частоту сенсоневральной тугоухости.
- **Экстренная химиопрофилактика контактных**
  1. ципрофлоксацин: 500 мг внутрь однократно;
  2. рифампицин: 600 мг внутрь каждые 12 часов **2 дня**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Менингококковая инфекция — острая антропонозная инфекционная болезнь с воздушно-капельным путём передачи возбудителя (Neisseria meningitidis), проявляющаяся интоксикацией, поражением слизистой оболочки носоглотки и возможной генерализацией в виде специфической септицемии и/или гнойного менингита с характерными изменениями в спинномозговой жидкости, появлением характерной геморрагической сыпи и реже — с поражением других органов и систем.

2.2 Этиология и эпидемиология

Возбудитель — Neisseria meningitidis, грамотрицательный неподвижный диплококк; в типичных случаях располагается попарно внутри нейтрофилов. Выделяют 12 серогрупп, подавляющее большинство заболеваний вызывают A, B, C, Y, X и W. Менингококки колонизируют носоглотку, вызывая бессимптомное носительство; предшествующая респираторная инфекция, особенно грипп, способствует генерализации.

Эпидемиология

1. источник — больные и носители; наибольшую опасность представляют носители и больные назофарингитом;
2. на одного больного манифестной формой приходится до 2 тыс. носителей; носительство длится в среднем 2–3 недели;
3. у 10–20% инфицированных развивается назофарингит, у 1–2% — генерализованная форма;
4. механизм передачи аспирационный, путь воздушно-капельный; 70% заражений происходит при контакте на расстоянии менее 0,5 м.

2.3 Классификация

Классификация по В. И. Покровскому

1. локализованные формы: менингококковое носительство, острый назофарингит;
2. генерализованные формы: менингококкемия, менингит;
3. сочетанная форма — менингит и менингококкемия;
4. редкие формы: миокардит, пневмония, иридоциклит, артрит, энцефалит, неврит зрительного нерва.

По тяжести течения выделяют лёгкую, среднетяжёлую, тяжёлую и фульминантную (молниеносную) формы.

2.4 Клиническая картина

Инкубационный период — **от 2 до 10 дней**, в среднем 4 дня. Менингококковый назофарингит — наиболее частое проявление инфекции; может предшествовать генерализованной форме (у 30–60% больных).

1. затруднение носового дыхания, скудные выделения из носа, небольшой кашель, головная боль;
2. у половины больных — лихорадка 1–4 суток, чаще субфебрильная;
3. слизистая оболочка передних отделов зева обычного вида, задняя стенка глотки гиперемирована, отёчна, с наложениями слизи; со 2–3-го дня — гиперплазия лимфоидных фолликулов;
4. воспалительные изменения особенно выражены в носоглотке и распространяются на заднюю часть хоан и носовых ходов.

Менингококкемия начинается остро среди полного здоровья или на фоне назофарингита.

1. **среднетяжёлая форма** — температура 38–39 °С, к концу первых — началу вторых суток необильная геморрагическая сыпь до 0,5 см на дистальных отделах конечностей и ягодицах
2. **тяжёлая форма** — температура 39–40 °С с выраженным ознобом, обильная крупная геморрагическая сыпь **в первые 12 часов**, с некрозами, на конечностях, лице и туловище; холодные конечности, снижение АД и диуреза — компенсированный инфекционно-токсический шок

При очень тяжёлом течении начало бурное (40–41 °С), сыпь с некрозами в первые часы, шок может развиться до появления сыпи; без адекватной терапии летальный исход наступает **в течение 1–2 суток**.

Менингит начинается остро: познабливание, головная боль, температура в первые сутки 38,5–39,5 °С.

1. головная боль быстро усиливается, становится распирающей, диффузной, не снимается анальгетиками; тошнота, рвота «фонтаном», гиперестезия кожи;
2. в конце 1-го или на 2-й день — менингеальные симптомы: ригидность мышц затылка, симптомы Брудзинского, Кернига;
3. **через 3–5 суток** без лечения — общемозговой синдром и очаговые симптомы, чаще поражение лицевого и глазодвигательных нервов — признаки отёка-набухания головного мозга;
4. серьёзным осложнением является гнойный лабиринтит и кохлеарный неврит, может появиться шум в ушах.

3. Диагностика

3.1 Жалобы и анамнез

Что уточнить

1. озноб, ломоту в теле, сроки появления и величину лихорадки, реакцию на жаропонижающие;
2. першение и боль в горле, затруднение носового дыхания, скудные выделения из носа, кашель, их давность;
3. сильную головную боль, тошноту и рвоту, повышенную чувствительность кожи;
4. сыпь: сроки появления, локализацию, характер и форму.

Эпидемиологический анамнез

1. контакт с больными генерализованной формой, лихорадящими, с катарально-респираторным синдромом;
2. выезд в регион с повышенной заболеваемостью;
3. нахождение в закрытом коллективе;
4. вакцинация **в последние 3 года**.

3.2 Физикальное обследование

При выраженной интоксикации, сильной головной боли и сыпи выполняется осмотр ротоглотки со шпателем для выявления фарингита и кожи — для выявления экзантемы; оцениваются менингеальные и очаговые симптомы, уровень сознания по шкале Глазго.

Для диагностики инфекционно-токсического шока и его степени определяют гипотермию конечностей, АД, ЧСС, ЧДД, объём и частоту мочеотделения.

3.3 Лабораторные исследования

Всем пациентам с подозрением на генерализованную форму выполняется посев слизи с задней стенки глотки на менингококк: исследование верифицирует этиологический диагноз назофарингита и устанавливает носительство.

При подозрении на менингит или сочетанную форму при поступлении исследуют спинномозговую жидкость; диагностическая спинномозговая пункция выполняется при менингеальных, общемозговых и очаговых симптомах при отсутствии противопоказаний.

Этиологическая диагностика при поступлении

1. посев спинномозговой жидкости на менингококк и крови на стерильность с определением серогруппы и чувствительности;
2. микроскопия спинномозговой жидкости и крови с окраской по Граму — ориентировочный метод;
3. реакция агглютинации латекса в спинномозговой жидкости — экспресс-метод;
4. ПЦР крови и спинномозговой жидкости на ДНК менингококка.

Всем при поступлении выполняются развёрнутый общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, кислотно-основное состояние и газы крови, СРБ и прокальцитонин, коагулограмма.

Генерализованная форма диагностируется клинически, если имеются характерные клинико-лабораторные проявления при отрицательных результатах посевов и ПЦР.

3.4 Инструментальные исследования

1. **КТ или МРТ головного мозга** — при появлении очаговой неврологической симптоматики, затяжном течении менингита без санации спинномозговой жидкости
2. **рентгенография или КТ лёгких** — при симптомах поражения дыхательной системы
3. **ЭКГ и эхокардиография** — всем пациентам с генерализованной формой при поступлении

3.5 Консультации специалистов

Осмотр оториноларинголога показан всем пациентам с генерализованной формой: возможен назофарингит, а при менингите — развитие сенсоневральной тугоухости.

1. **анестезиолог-реаниматолог** — при артериальной гипотензии, цианозе, судорогах, нарушении сознания и дыхания
2. **невролог** — при подозрении на менингит, общемозговой и очаговой симптоматике
3. **хирург** — при интенсивных болях в животе
4. **офтальмолог** — при подозрении на менингит, внутричерепной гипертензии, поражении органа зрения

3.6 Дифференциальная диагностика

1. **назофарингит** — с другими поражениями носоглотки (ОРВИ); предположительный диагноз возможен только при вспышке в коллективе и требует лабораторного подтверждения
2. **менингеальные симптомы на фоне интоксикации** — с другими гнойными, серозными вирусными и туберкулёзным менингитами, с менингизмом при острых лихорадочных заболеваниях

---

4. Лечение

4.1 Локализованные формы и носительство

Для эрадикации носительства и лечения подтверждённых локализованных форм применяют средние терапевтические дозы препаратов, активных в отношении менингококка, внутрь.

1. амоксициллин + клавулановая кислота: 250 мг + 125 мг 3 раза в сутки;
2. цефиксим: 400 мг 1 раз в день;
3. ципрофлоксацин: 500 мг 2 раза в сутки;
4. левофлоксацин: 500 мг 1 раз в сутки.

4.2 Генерализованные формы

Препаратами первого выбора являются цефалоспорины III поколения — цефтриаксон и цефотаксим — в максимальных суточных дозах внутривенно **7–10 дней**.

Контрольная спинномозговая пункция

1. при среднетяжёлом течении — **на 7–10-е сутки**;
2. при тяжёлом течении менингита — **на 3–5–7-й день**.

Цефтриаксон недопустимо применять с растворами, содержащими кальций. Также применяют цефепим, бензилпенициллин, ампициллин, ципрофлоксацин с учётом региональной чувствительности.

Меропенем не является препаратом первой линии: его назначают при вторичных бактериальных осложнениях в ОРИТ с учётом чувствительности и эмпирически при выраженной нейтропении.

Антибиотики при генерализованной форме вводятся только парентерально; внутривенное введение начинают **не позднее 1 часа** после поступления и постановки диагноза: каждый час задержки увеличивает летальность.

На догоспитальном этапе антибиотик вводят только при веских подозрениях на генерализованную форму (клиника с геморрагической сыпью), при обеспеченном сосудистом доступе, тяжёлом прогрессирующем состоянии и невозможности госпитализации **в течение 90 минут**.

При менингите, осложнённом отёком-набуханием головного мозга, вводится дексаметазон 4 мг внутривенно до начала антибактериальной терапии или одновременно с ней. Дексаметазон не влияет на летальность, но снижает частоту сенсоневральной тугоухости.

Генерализованная форма с отёком мозга и/или инфекционно-токсическим шоком лечится в ОРИТ.

При инфекционно-токсическом шоке препаратом первой линии вазопрессорной терапии является норэпинефрин; целевое среднее АД — **более 65 мм рт. ст.**

При лихорадке **выше 38,5 °C** и болевом синдроме применяют ибупрофен, парацетамол, диклофенак, кетопрофен.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Лицам, находившимся в тесном контакте с больным, проводится экстренная химиопрофилактика таблетированными препаратами.

1. ципрофлоксацин: 500 мг внутрь однократно;
2. рифампицин: 600 мг внутрь каждые 12 часов **2 дня**.

В очагах генерализованной формы выявляют больных острым назофарингитом и до начала лечения выполняют им посев слизи с задней стенки глотки на менингококк. Больного генерализованной формой изолируют в отдельном боксе до полного клинического выздоровления.

В межэпидемический период вакцинируют в плановом порядке лиц из групп высокого риска, по эпидемическим показаниям — контактных в очагах генерализованной формы.

Диспансерное наблюдение у инфекциониста — **в течение 12 месяцев**. После выписки от профилактических прививок воздерживаются **3 месяца** при среднетяжёлом и **6 месяцев** при тяжёлом течении, кроме столбнячного анатоксина и вакцины против бешенства.

5.2 Показания к госпитализации

Больные и пациенты с подозрением на генерализованную форму подлежат обязательной экстренной госпитализации в инфекционную больницу или отделение с ОРИТ.

Амбулаторное лечение назофарингита и носительства допускается

1. только при лабораторно подтверждённом диагнозе;
2. при проживании в отдельной благоустроенной квартире без контакта с работниками детских и лечебных организаций;
3. при обеспеченном уходе и противоэпидемическом режиме;
4. при отсутствии признаков генерализованной формы и возможности наблюдения на дому.

Исключение — проживающие в интернатах, отелях, хостелах и пациенты с аллергией на препараты выбора.

Критерии выписки

1. регресс менингеальных симптомов, лихорадки и сыпи;
2. нормализация общего анализа крови;
3. санация спинномозговой жидкости: белок **менее 0,45 г/л**, лимфоцитарный цитоз **ниже 100 в 1 мкл**, глюкоза **выше 2 ммоль/л**, лактат **менее 3,0 ммоль/л**;
4. отрицательные результаты посева спинномозговой жидкости и ПЦР крови.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Менингококковая инфекция»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 23.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	`1020_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Раздел 1.6 указывает, что точный диагноз назофарингита устанавливается только микроскопией мазков с задней стенки глотки, а раздел 2.3 и условия амбулаторного лечения требуют посева (культурального исследования) слизи с задней стенки глотки.

Клинические рекомендации

Менингококковая инфекция у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**A39** — Менингококковая инфекция **Z22.3** — Носительство возбудителей других уточненных бактериальных болезней
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 03.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/58_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Менингококковая инфекция — антропонозное заболевание с воздушно-капельным путём передачи; протекает как бактерионосительство, назофарингит, менингококкемия и гнойный менингит. Входные ворота — слизистые оболочки носо- и ротоглотки.
- **Признаки генерализованной формы**
  1. острейшее начало со стойкой фебрильной лихорадкой, часто двухволновой: вторая волна **через 2–6 часов** не снижается жаропонижающими;
  2. геморрагическая сыпь, не исчезающая при надавливании; ей нередко предшествует розеолёзная сыпь, принимаемая за аллергию;
  3. боли в мышцах, суставах, животе, головная боль, рвота, снижение диуреза.
- Назофарингит клинически не специфичен: диагноз устанавливается только при бактериологическом подтверждении. Локализованные формы лечат амбулаторно антибиотиками внутрь, если не требуется изоляция.
- При подозрении на генерализованную форму показана экстренная госпитализация в стационар с отделением реанимации; антибиотики на догоспитальном этапе вводят только при веских подозрениях (клиника и геморрагическая сыпь) и налаженном сосудистом доступе.
- При менингококковом менингите для раннего выявления поражения слухового анализатора исследуют акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП).

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Менингококковая инфекция — антропонозное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём и протекающее в виде бактерионосительства, назофарингита, менингококкемии и гнойного менингита, реже — с поражением других органов и систем.

2.2 Этиология, патогенез и эпидемиология

Возбудитель — Neisseria meningitidis, грамотрицательный диплококк; патогенны для человека серогруппы A, B, C, W, Y, X. Менингококк попадает на слизистую оболочку носоглотки, где быстро гибнет или вегетирует (носительство); в 10–15% случаев при сниженной резистентности и дефиците секреторного IgA развивается назофарингит. Генерализация сопровождается бактериемией, эндотоксинемией и системной воспалительной реакцией.

Группы риска генерализованных форм

1. дети раннего возраста, подростки, призывники;
2. лица, живущие в условиях скученности;
3. иммунодефициты;
4. кохлеарная имплантация, открытая черепно-мозговая травма, ликворея.

Эпидемиология

1. источник — носители и больные назофарингитом;
2. пути передачи — воздушно-капельный, контактно-бытовой;
3. инкубационный период **2–10 дней**, чаще 2–3 дня;
4. сезонность — зима и весна; периодичность подъёмов 28–30 лет.

В структуре заболеваемости носительство составляет 40–43%, назофарингит — 3–5%, менингококкемия — 36–43%, менингит — 10–25%, смешанная форма — 47–55%.

2.3 Классификация

Классификация В. И. Покровского

1. **локализованные формы** — менингококконосительство, острый назофарингит
2. **генерализованные формы** — менингококкемия (типичная, молниеносная, хроническая), менингит, менингоэнцефалит, смешанная форма
3. **редкие формы** — эндокардит, артрит (синовит), полиартрит, пневмония, иридоциклит

2.4 Клиническая картина

Для генерализованной формы характерно острейшее начало с внезапной вялостью на фоне фебрильной температуры. До появления геморрагической «звёздчатой» сыпи (элементы разбросаны, как звёзды на небе) заподозрить менингококковую природу вне очага практически невозможно.

Жизнеугрожающие осложнения

1. септический шок;
2. ДВС-синдром;
3. острая почечная недостаточность;
4. отёк головного мозга.

Лихорадка может быть двухволновой: после первого подъёма, который снижается парацетамолом или ибупрофеном, следует период относительного благополучия, затем повторный подъём, плохо поддающийся жаропонижающим.

---

3. Диагностика

3.1 Жалобы и анамнез

Что уточняют

1. контакты в семье и ближнем окружении;
2. пребывание в регионах с высокой заболеваемостью («менингитный пояс» Африки, Саудовская Аравия);
3. жалобы высокого риска генерализованной формы: острейшее начало, стойкая фебрильная лихорадка, геморрагическая сыпь, боли в мышцах, суставах, животе, головная боль, рвота, снижение диуреза.

Боли в животе и конечностях на фоне лихорадки относятся к «красным флагам» генерализованных бактериальных инфекций и нередко предшествуют септическому шоку. Распространённая геморрагическая сыпь без предшествующей розеолёзной через несколько часов от дебюта свидетельствует о крайней тяжести.

3.2 Физикальное обследование

Генерализованную форму предполагают при геморрагической сыпи, не исчезающей при надавливании, на фоне лихорадки.

Для оценки тяжести оценивают

1. уровень сознания;
2. температуру и окраску кожи, время капиллярного наполнения;
3. АД, частоту и характер дыхания, диурез;
4. менингеальные и очаговые симптомы.

3.3 Лабораторные исследования

Всем при подозрении на генерализованную форму

1. общий и биохимический анализы крови, кислотно-основное состояние и газы крови;
2. СРБ и прокальцитонин;
3. гемостаз: время кровотечения и свёртываемости, коагулограмма;
4. посев крови на стерильность;
5. посев слизи с задней стенки глотки и со слизистой оболочки носа на менингококк — вне зависимости от формы;
6. ПЦР крови на ДНК менингококка.

Исследование ЦСЖ при подозрении на смешанную форму или менингит

1. цитоз;
2. белок, глюкоза, натрий, хлориды, лактат;
3. посев, ПЦР на ДНК менингококка;
4. реакция латекс-агглютинации, микроскопия мазка по Граму.

Диагноз менингококкового менингита устанавливается только по результатам исследования ЦСЖ.

1. **достоверный диагноз** — типичная клиника локализованной или генерализованной формы и выделение культуры менингококка из стерильных жидкостей (кровь, ликвор, синовиальная жидкость) либо ДНК при ПЦР
2. **вероятный диагноз** — характерные клинико-лабораторные проявления при отрицательном бактериологическом обследовании

3.4 Инструментальные исследования

1. **ЭКГ и эхокардиография** — всем с генерализованной формой
2. **рентгенография грудной клетки** — при подозрении на пневмонию, в ОРИТ
3. **УЗИ головного мозга** — при подозрении на бактериальный гнойный менингит
4. **офтальмоскопия** — перед спинномозговой пункцией при подозрении на менингит
5. **ЭЭГ** — при отёке мозга, судорогах, энцефалопатии
6. **КТ или МРТ головного мозга** — при новой очаговой симптоматике, затяжном менингите без санации ЦСЖ

Пациентам с менингококковым менингитом исследуют акустические стволовые вызванные потенциалы: метод выявляет на ранних сроках повреждение слухового анализатора, которое может развиться при генерализованной форме и менингите, и позволяет оценить состояние стволовых структур мозга.

При экзантеме проводят дифференциальную диагностику с заболеваниями, протекающими с геморрагической и пятнисто-папулёзной сыпью; при плеоцитозе ЦСЖ — с менингитами иной этиологии и неинфекционными заболеваниями.

4. Лечение

4.1 Локализованные формы

Применяют средние терапевтические дозы антибиотиков, активных в отношении N. meningitidis, в формах для приёма внутрь: пенициллины широкого спектра (ампициллин, амоксициллин), комбинации пенициллинов с ингибиторами бета-лактамаз.

1. ампициллин, масса тела до 20 кг: 12,5–25 мг/кг в сутки (так в тексте КР, см. «Неточности»);
2. ампициллин, масса тела более 20 кг: 250–500 мг каждые 6 часов.

Детям с локализованными формами проводят коротковолновое ультрафиолетовое облучение зева и носа, лазеротерапию.

4.2 Генерализованные формы

Антибиотики вводят только парентерально, при подозрении на гнойный менингит — в максимальных для возраста дозах.

1. **без септического шока** — допустимо внутримышечно
2. **септический шок** — только внутривенно или внутрикостно
3. **нет геморрагической сыпи, подозрение на гнойный менингит** — антибиотик до госпитализации — только если госпитализация невозможна **в течение 90 минут**; до этого берут кровь, ЦСЖ, мазки из носоглотки

Препараты первого выбора — цефалоспорины III поколения (цефтриаксон несовместим с растворами, содержащими кальций). Меропенем назначают при вторичных бактериальных осложнениях в ОРИТ и выраженной нейтропении. Хлорамфеникол — детям **старше 3 лет** только при тяжёлой аллергии на бета-лактамы.

Глюкокортикоиды при установленной менингококковой этиологии менингита не рекомендуются; положительных эффектов при менингококковом менингите не выявлено.

1. **дексаметазон** — снижает частоту сенсоневральной тугоухости лишь при гемофильном менингите, если введён до антибиотика
2. **гидрокортизон** — заместительная терапия при септическом шоке, резистентном к адренергическим и дофаминергическим средствам

Патогенетическая и интенсивная терапия

1. инфузионная терапия для поддержания объёма циркулирующей крови и коррекции метаболических нарушений;
2. иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного введения;
3. осмодиуретики при отёке мозга, кардиотоники при шоке, рефрактерном к жидкостной нагрузке;
4. экстракорпоральная гемокоррекция при септическом шоке и синдроме Уотерхауса — Фридериксена;
5. перевод на ИВЛ при рефрактерном шоке, церебральной недостаточности (**менее 9 баллов** по шкале Глазго), судорожном статусе.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Лицам, находившимся в тесном контакте с больным, проводится экстренная химиопрофилактика.

1. рифампицин старше 12 месяцев: 10 мг/кг каждые 12 часов 2 дня;
2. рифампицин до 1 года: 5 мг/кг каждые 12 часов 2 дня;
3. цефтриаксон: 125 мг в/м однократно.

В межэпидемический период вакцинируют лиц из групп высокого риска, по эпидемическим показаниям — контактных в очагах генерализованной формы. По эпидемическим показаниям также прививают детей **от 1 года до 8 лет** включительно и студентов первых курсов.

Детей, перенёсших менингит и (или) менингоэнцефалит, наблюдает невролог **в течение 2 лет**: **через 1 месяц** после выписки, затем 1 раз в 3 месяца в первый год и 1 раз в 6 месяцев в дальнейшем.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. подозрение на генерализованную форму — экстренно, в стационар с отделением реанимации;
2. необходимость изоляции при локализованной форме по эпидемиологическим показаниям;
3. серьёзные аллергические реакции на антибиотики в анамнезе.

Локализованные формы (назофарингит, носительство) лечат амбулаторно, если не требуется изоляция (дети дошкольного возраста в квартире, дома ребёнка, интернаты).

Критерии выписки

1. клиническое выздоровление;
2. нормализация лабораторных показателей.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Менингококковая инфекция у детей»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 03.03.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	58_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Доза ампициллина при локализованных формах у детей массой до 20 кг указана как «12,5–25 мг/кг/сутки», а у детей более 20 кг — 250–500 мг каждые 6 часов (1–2 г в сутки): суточная доза для детей до 20 кг оказывается в несколько раз меньше; вероятно, имеется в виду доза на приём.

Клинические рекомендации

Мигрень

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**G43** — Мигрень **G43.0** — Мигрень без ауры [простая мигрень] **G43.1** — Мигрень с аурой [классическая мигрень] **G43.2** — Мигренозный статус **G43.3** — Осложненная мигрень **G43.8** — Другая мигрень **G43.9** — Мигрень неуточненная **G44.0** — Синдром «гистаминовой» головной боли **G44.1** — Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках **G44.4** — Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"; Межрегиональная общественная организация "Российское общество по изучению головной боли"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/295_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Мигрень — первичная головная боль: приступы пульсирующей односторонней боли длительностью **4–72 часа** с повышенной чувствительностью к свету и звуку, тошнотой и/или рвотой. Обычно начинается **до 20 лет**; женщины болеют в 2,5–3 раза чаще.
- Диагноз клинический — по критериям МКГБ-3. При типичной мигрени дополнительные исследования не нужны; при редких формах ауры, осложнениях и «сигналах опасности» показаны МРТ головного мозга и МР-ангиография, консультации офтальмолога, оториноларинголога, психотерапевта.
- При мигрени со стволовой аурой наряду со зрительными, чувствительными и речевыми нарушениями возникают обратимые стволовые симптомы: дизартрия, головокружение, шум в ушах, снижение слуха, диплопия, атаксия, изменение сознания.
- Лёгкий и средний приступ купируют анальгетиками и НПВП (препарат первого выбора — ибупрофен 400 мг), тяжёлый — триптанами **в первые 30 минут** от начала боли. Профилактика показана при **3 и более** тяжёлых приступах или **8 и более** днях с болью в месяц.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Мигрень (М) — первичная форма головной боли (ГБ), проявляющаяся приступами пульсирующей односторонней боли продолжительностью **4–72 часа**, которая сопровождается повышенной чувствительностью к свету, звуку, тошнотой и/или рвотой.

Мигрень обычно возникает **до 20 лет**; в детстве чаще у мальчиков, у взрослых женщины болеют в 2,5–3 раза чаще. Максимум частоты и интенсивности приступов — в 35–45 лет, после 55–60 лет течение облегчается или приступы прекращаются.

2.2 Этиология и эпидемиология

Мигрень — хроническое нейроваскулярное заболевание с наследственной предрасположенностью. Основное звено патогенеза — периодическое периваскулярное нейрогенное воспаление сосудов твёрдой мозговой оболочки при повышенной возбудимости коры и тригеминоваскулярной системы. Механизм ауры — распространяющаяся корковая депрессия.

Распространённость мигрени в Европе и США — около 14%, в России за год — 15,9–20,8%.

2.3 Классификация

Две основные формы: мигрень без ауры — до 80% случаев, мигрень с аурой — до 20%. Реже встречаются мигрень со стволовой аурой (ранее «базилярная»), ретинальная и гемиплегическая мигрень.

Классификация мигрени (МКГБ-3, 2018)

1. мигрень без ауры;
2. мигрень с аурой: с типичной аурой, со стволовой аурой, гемиплегическая, ретинальная;
3. хроническая мигрень;
4. осложнения мигрени: мигренозный статус, персистирующая аура без инфаркта, мигренозный инфаркт, аура — триггер эпилептического припадка;
5. возможная мигрень;
6. эпизодические синдромы: синдром циклических рвот, абдоминальная мигрень, доброкачественное пароксизмальное головокружение, доброкачественный пароксизмальный тортиколлис.

2.4 Клиническая картина

Мигрень без ауры — повторяющиеся однотипные приступы интенсивной, чаще односторонней пульсирующей боли, которая усиливается при нагрузке; приступ длится **от 4 часов до 3 суток**.

1. **локализация** — преимущественно висок, глаз, темя; нередко начало в затылке
2. **сопровождающие симптомы** — тошнота, рвота, повышенная чувствительность к свету и звукам

Частота при эпизодической мигрени — от 1 дня в год до 14 дней в месяц (в среднем 2–4), при хронической — **15 и более дней в месяц**.

При мигрени с аурой фазе боли предшествуют преходящие неврологические нарушения. При типичной ауре — полностью обратимые зрительные, чувствительные и/или речевые симптомы без двигательных и стволовых; в редких случаях боль после ауры не развивается.

1. **мигрень со стволовой аурой** — два или более обратимых стволовых симптома: дизартрия, головокружение, шум в ушах, снижение слуха, диплопия, атаксия, изменение уровня сознания
2. **гемиплегическая мигрень** — чрезвычайно редкая, почти всегда наследственная; обратимые двигательные нарушения **до 72 часов**
3. **ретинальная мигрень** — обратимые односторонние зрительные феномены (вспышки, скотомы), подтверждённые исследованием полей зрения во время приступа

Наиболее частые триггеры приступа

1. стресс или расслабление после стресса, тревога, депрессия, переутомление;
2. изменения погоды;
3. менструация, овуляция, эстрогенсодержащая гормональная терапия и оральные контрацептивы;
4. голод, некоторые продукты (сыр, шоколад, орехи, копчёности, куриная печень, авокадо, цитрусовые, кофеинсодержащие продукты), алкоголь, особенно красное вино;
5. недостаток или избыток сна, духота, аэробная нагрузка, яркий или мерцающий свет, шум, пребывание на высоте.

1. **хроническая мигрень** — 15 и более дней с болью в месяц; коморбидные психические расстройства, нарушения сна, снижение эффективности средств для купирования
2. **мигренозный статус** — изнуряющий приступ **более 72 часов** с ремиссиями до 12 часов
3. **персистирующая аура без инфаркта** — симптомы ауры **более 1 недели** без признаков инфаркта мозга
4. **мигренозный инфаркт** — симптомы ауры **более 60 минут** с ишемическим повреждением, подтверждённым нейровизуализацией
5. **аура — триггер эпилептического припадка** — припадок во время приступа мигрени с аурой или **в течение 1 часа** после него

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Всем пациентам с жалобой на головную боль проводится клиническая диагностика мигрени по критериям МКГБ-3.

Диагностические критерии мигрени без ауры

1. A. Не менее 5 приступов, отвечающих критериям B–D.
2. B. Продолжительность **4–72 часа** без лечения или при его неэффективности.
3. C. Не менее 2 из 4 характеристик: односторонняя локализация; пульсирующий характер; средняя или выраженная интенсивность; усиление от обычной физической активности.
4. D. Не менее 1 симптома: тошнота и/или рвота; фотофобия и фонофобия.
5. E. Боль не соответствует лучше другому диагнозу МКГБ-3.

Диагностические критерии мигрени с аурой

1. A. Не менее 2 приступов, отвечающих критериям B и C.
2. B. Один или более полностью обратимых симптомов ауры: зрительные, сенсорные, речевые, двигательные, стволовые, ретинальные.
3. C. Не менее 3 из 6 характеристик: постепенное нарастание симптома **более 5 минут**; последовательное возникновение симптомов; каждый длится **5–60 минут**; хотя бы один симптом односторонний; хотя бы один позитивный; боль во время ауры или **в течение 60 минут** после неё.
4. D. Другой диагноз МКГБ-3 не подходит в большей степени.

Ауру не путают с продромальными симптомами за несколько часов до приступа: повышенной чувствительностью к свету, звукам и запахам, изменением аппетита, жаждой, эмоциональным возбуждением или разбитостью.

Диагностические критерии хронической мигрени

1. A. Головная боль **15 и более дней в месяц** на протяжении **3 и более месяцев**.
2. B. В анамнезе не менее 5 приступов мигрени без ауры и/или с аурой.
3. C. **8 и более дней в месяц** в течение 3 месяцев боль соответствует мигрени или купируется триптанами либо эрготамином.
4. D. Другой диагноз МКГБ-3 не подходит в большей степени.

Число дней с болью за 3 месяца устанавливают расспросом и по дневнику; важный критерий — типичные приступы эпизодической мигрени в начале заболевания.

3.2 Лекарственно-индуцированная головная боль

Частая эпизодическая (более 10 дней с болью в месяц) и хроническая мигрень могут сочетаться с лекарственным абузусом — ведущим фактором хронизации. ЛИГБ диагностируется при головной боли **более 15 дней в месяц** у пациента с первичной головной болью и регулярном злоупотреблении препаратами для купирования **более 3 месяцев**.

ЛИГБ проявляется диффузной монотонной, чаще утренней или ночной болью, нарастающей с прекращением действия препарата. Наибольший риск — у препаратов с кодеином, барбитуратами и кофеином; при выявлении ЛИГБ выставляются два диагноза.

Формы ЛИГБ по числу дней приёма

Препараты злоупотребления	Число дней с приёмом в месяц (3 месяца и более)
эрготаминсодержащие препараты, триптаны	10 и более

Препараты злоупотребления	Число дней с приёмом в месяц (3 месяца и более)
парацетамол, НПВП, ацетилсалициловая кислота, другие анальгетики и антипиретики	15 и более
опиоиды, анальгетики с компонентами разных классов, комбинации нескольких классов, другие препараты	10 и более

3.3 Жалобы и анамнез

Типичные жалобы

1. повторяющиеся приступы односторонней пульсирующей боли в лобно-височной или теменной области;
2. интенсивность средняя или выраженная — более 7 баллов по ВАШ;
3. продолжительность **4–72 часа**, усиление от обычной физической активности;
4. тошнота и/или рвота, повышенная чувствительность к свету и звукам;
5. при ауре — нарушения, нарастающие 5–20 минут и длящиеся **не более 60 минут**.

Характерный анамнез

1. первые приступы **до 20 лет**;
2. аналогичные головные боли у родственников;
3. урежение или прекращение приступов во время беременности и в менопаузе;
4. ухудшение при стрессе, депрессии, тревоге, злоупотреблении обезболивающими, приёме оральных контрацептивов, в преклимаксе.

У всех пациентов выявляют коморбидные нарушения — прежде всего депрессию, тревожные расстройства, нарушения сна и другие болевые синдромы: они утяжеляют течение и способствуют хронизации.

3.4 Физикальное обследование

Исследуется неврологический статус для исключения органической симптоматики; при типичной мигрени изменений нет.

Возможные находки

1. снижение настроения, тревожность;
2. вегетативные нарушения, симптом Хвостека I–III степени;
3. напряжение и болезненность перикраниальных мышц.

При менингеальных, общемозговых или очаговых знаках проводятся дополнительные исследования.

3.5 Лабораторные исследования

При типичной картине и нормальном неврологическом статусе лабораторные исследования не рекомендуются. При атипичной картине, «сигналах опасности» или осложнениях выполняются общий (клинический) анализ крови, исследования общевоспалительных реакций и коагулограмма.

3.6 Инструментальные исследования и консультации

Без атипичных черт и неврологических нарушений инструментальные исследования не рекомендуются; единичные субклинические очаги в белом веществе на МРТ маркерами мигрени не являются.

При редких формах ауры и осложнениях мигрени для исключения аневризмы, артериовенозной мальформации, диссекции сонных артерий выполняются МРТ головного мозга, МР-ангиография, МР-венография; при невозможности МРТ — КТ и КТ-ангиография.

При нетипичном течении или «сигналах опасности» — МРТ и МР-ангиография, при необходимости консультации офтальмолога, оториноларинголога, психотерапевта.

«Сигналы опасности»

1. боль, впервые возникшая после 50 лет, или изменившая течение;
2. «громоподобная» боль, нарастающая до 10 баллов по ВАШ **за 1–2 секунды**;
3. строго односторонняя боль;
4. прогрессивно ухудшающаяся боль без ремиссий;
5. внезапная, необычная для пациента боль;
6. атипичная аура: необычные нарушения и/или продолжительность **более 1 часа**;
7. изменения сознания или психические нарушения;
8. очаговые знаки и симптомы системного заболевания: лихорадка, сыпь, ригидность шейных мышц, артралгии, миалгии;
9. признаки внутричерепной гипертензии;
10. отёк диска зрительного нерва;
11. ВИЧ-инфекция, онкологическое, эндокринное, системное заболевание или травма головы в анамнезе;
12. дебют во время беременности или в послеродовом периоде;
13. неэффективность адекватного лечения.

3.7 Дневник головной боли

Дневник **в течение 1–3 месяцев** до осмотра позволяет установить характеристики приступа, число дней с болью и с приёмом обезболивающих, отличить приступ мигрени от эпизода ГБН и выявить лекарственный абузус.

3.8 Дифференциальная диагностика

Чаще всего мигрень дифференцируют с ГБН, кластерной головной болью, хронической пароксизмальной гемикранией и цервикогенной головной болью.

Мигренеподобная боль возможна при

1. транзиторной ишемической атаке и инсульте;
2. гигантоклеточном артериите;
3. диссекции артерий, аневризмах, артериовенозных мальформациях;
4. церебральном венозном тромбозе;
5. опухоли головного мозга;
6. субарахноидальном кровоизлиянии;
7. антифосфолипидном синдроме и тромбофилиях;
8. эпилепсии;
9. синдромах MELAS и CADASIL.

Эти заболевания всегда проявляются неврологическим дефицитом или другими «сигналами опасности». Сочетающиеся формы головной боли вносятся в диагноз.

Для ауры типично постепенное нарастание симптомов на одной стороне тела за 10–30 (до 60) минут — «марш» со сменой позитивных и негативных симптомов.

1. зрительные феномены: мерцание, зигзаги, тёмные пятна, скотомы;
2. затем парестезии и онемение от кисти к плечу и лицу;
3. далее речевые расстройства;
4. в конце ауры — мигренозная боль.

При ТИА нарушения негативные и возникают остро и одновременно; боль не характерна, мигрени в анамнезе, как правило, нет.

Хроническую мигрень дифференцируют с хронической ГБН, новой ежедневной персистирующей головной болью и гемикранией континуа; опираются на ранний анамнез — типичные приступы эпизодической мигрени, наследственность, мигренозные триггеры, облегчение во время беременности.

Мигрень плохо диагностируется: вместо неё ставят дисциркуляторную энцефалопатию, остеохондроз шейного отдела, вегетососудистую дистонию, цервикогенную головную боль, боль при артериальной гипертензии — из-за трактовки неспецифических изменений УЗДГ и рентгенографии как органических. Неверный диагноз ведёт к назначению психостимуляторов и ноотропов, которые способствуют хронизации.

---

4. Лечение

Лечение включает три подхода: поведенческую терапию, купирование приступов и профилактическое лечение. Цели — уменьшение частоты и тяжести приступов и числа принимаемых обезболивающих, коррекция коморбидных нарушений, профилактика хронизации.

Поведенческая терапия

1. разъяснение доброкачественной природы мигрени;
2. обоснование нецелесообразности дополнительных исследований;
3. роль провокаторов приступов и необходимость их избегать;
4. факторы хронизации: стресс, лекарственный абузус, коморбидные нарушения;
5. цели лечения и действие профилактических препаратов;
6. при злоупотреблении обезболивающими — временный отказ от них и строгий контроль их числа.

4.1 Купирование приступа

1. **лёгкий приступ** — пациент способен выполнять привычную домашнюю и профессиональную работу
2. **приступ средней тяжести** — эти виды деятельности существенно ограничены
3. **тяжёлый приступ** — необходим постельный режим

Терапию назначают в зависимости от тяжести приступа и степени дезадаптации.

Купирование лёгкого и среднего приступа

Препарат	Разовая доза	УУР
ацетилсалициловая кислота — препарат выбора	1000 мг внутрь	A
ибупрофен — препарат выбора	400 мг внутрь	A
напроксен — препарат выбора	500 мг внутрь	C

Препарат	Разовая доза	УУР
парацетамол — препарат выбора	1000 мг внутрь	A
диклофенак — препарат выбора, порошок для раствора внутрь	50 мг	A
кетопрофен	75 или 150 мг внутрь	B
ацетилсалициловая кислота + кофеин + парацетамол	2 таблетки внутрь	B

Принципы применения анальгетиков и НПВП

1. НПВП и ацетилсалициловая кислота эффективнее парацетамола;
2. препарат первого выбора — ибупрофен 400 мг: наименьший риск желудочно-кишечных осложнений;
3. для контроля приёма ведётся дневник;
4. учитывают действие НПВП на ЖКТ и риск кровотечений;
5. не рекомендуются метамизол натрия (агранулоцитоз), опиоиды, препараты с кодеином или барбитуратами (абузус и ЛИГБ);
6. быстрорастворимые формы действуют быстрее: кетопрофен (лизиновая соль) 40 или 80 мг, диклофенак 50 мг в порошке.

При тошноте и рвоте вместе с анальгетиком применяют противорвотные средства: они уменьшают гастростаз и улучшают всасывание обезболивающих.

1. метоклопрамид: 10 мг внутримышечно или 10–20 мг внутрь
2. домперидон: 10 мг 3 раза в сутки внутрь

При тяжёлых приступах и неэффективности анальгетиков и НПВП применяют триптаны; они наиболее эффективны и могут применяться и при приступах средней тяжести.

Триптаны для купирования приступа

Триптан	Разовая доза
суматриптан	50 или 100 мг внутрь
элетриптан	40 или 80 мг внутрь
золмитриптан	2,5 или 5 мг внутрь или назальный спрей
ризатриптан	10 мг внутрь или диспергируемые в полости рта таблетки

Правила приёма триптанов

1. в самом начале приступа — **в первые 30 минут** от начала боли;
2. не меньше суматриптан 50 мг, элетриптан 40 мг, золмитриптан 2,5 мг, ризатриптан 10 мг;
3. при мигрени с аурой — не во время ауры, а в конце её или в начале фазы боли;
4. не более **10 дней в месяц**; повторная доза — **через 2 часа**, не более 2 доз в сутки;
5. при неэффективности одного триптана пробуют другие.

Противопоказания: ишемическая болезнь сердца, окклюзионные заболевания периферических сосудов, неконтролируемая артериальная гипертензия, мигрень со стволовой аурой.

Наиболее безопасен при сердечно-сосудистом риске элетриптан; назальный спрей золмитриптана начинает действовать **через 15 минут** и предпочтителен при выраженной тошноте и рвоте.

При тяжёлом приступе, особенно при невозможности приёма внутрь из-за тошноты и рвоты, применяется #кеторолак 60 мг внутримышечно или 30 мг внутривенно.

4.2 Мигренозный статус

При мигренозном статусе применяют триптаны, если пациент не принимал их для купирования приступа.

В стационаре статус купируют парентеральным введением препаратов, выбор которых определяется картиной и тяжестью; лечение проводится в тихом затемнённом помещении.

Купирование мигренозного статуса

Препарат	Разовая доза и путь введения
метоклопрамид	10 мг внутривенно капельно в 50 мл раствора натрия хлорида за 20 минут
#хлорпромазин	0,1 мг/кг внутривенно капельно
#декскетопрофен	50 мг внутривенно
#кеторолак	60 мг внутримышечно или 30 мг внутривенно
#магния сульфат — только при статусе мигренозной ауры	2 г внутривенно капельно
#вальпроевая кислота — не у женщин детородного возраста	800–1000 мг внутривенно
#дексаметазон — для предотвращения возврата приступа	10–24 мг внутривенно

Внутривенное введение дроперидола и галоперидола не рекомендуется из-за риска побочных реакций. Перед назначением антипсихотических средств выполняется ЭКГ (удлинённый QT — противопоказание). Парентеральное введение жидкостей показано только при повторной рвоте и дегидратации.

4.3 Профилактическая терапия

Профилактика показана при **3 и более** тяжёлых дезадаптирующих приступах в месяц при адекватном купировании или **8 и более днях** с болью в месяц, а также при пролонгированной ауре даже при редких приступах.

Другие показания

1. неэффективность или плохая переносимость средств купирования;
2. хроническая мигрень;
3. лекарственный абузус, ЛИГБ;
4. мигренозный инфаркт или статус в анамнезе, мигрень со стволовой аурой, гемиплегическая мигрень;
5. тяжёлые коморбидные нарушения;
6. предпочтение пациента.

Принципы профилактического лечения

1. начинать с монотерапии препаратом с доказанной эффективностью, медленно повышая дозу;
2. оценивать эффект **через 3 месяца**: эффективно, если число дней с болью снизилось **на 50% и более**; ботулинотерапию — не ранее чем через 6 месяцев;
3. при эффекте — продолжать **6–12 месяцев**, затем постепенная отмена;
4. избегать избыточного приёма средств купирования (чаще 2 дней в неделю);
5. учитывать коморбидные заболевания;
6. длительность — **6 месяцев** при эпизодической и **12 месяцев** при хронической мигрени.

Препараты для профилактики мигрени

Препарат	Суточная доза	УУР
метопролол — первый выбор	100–200 мг внутрь	B
пропранолол — первый выбор	80–160 мг внутрь	A
топирамат — первый выбор; титрация с 25 мг, основная доза вечером, курс до 12 месяцев	100 мг, возможно до 200 мг	B
ботулинический токсин типа A — первый выбор, только при хронической мигрени	155–195 ЕД по протоколу PREEMPT каждые 12 недель	A
фреманезумаб, эренумаб — первый выбор при 4 и более днях с болью в месяц	фреманезумаб 225 мг подкожно ежемесячно или 675 мг раз в 3 месяца; эренумаб 70 или 140 мг подкожно ежемесячно	A
#атенолол — второй выбор	100 мг	B
#амитриптилин, #венлафаксин — второй выбор	50–150 мг; 75–150 мг	B
#кандесартан — второй выбор	16 мг	B
#вальпроевая кислота — второй выбор, нежелательна у женщин с детородным потенциалом	400–1500 мг внутрь	A

Моноклональные антитела к CGRP назначают **от 6 до 12 месяцев** и более, эффективность оценивают **через 3 месяца**; при хронической мигрени курс продлевают до 18 месяцев. Ботулотоксин вводят в 7 групп мышц головы и шеи; эффект одной процедуры сохраняется около 3 месяцев.

4.4 Лечение мигрени с лекарственно-индуцированной головной болью

Частая эпизодическая мигрень (8 и более дней с болью и 8–10 дней с приёмом обезболивающих в месяц) — группа риска ЛИГБ: пациентам разъясняют безопасный режим — **не чаще 2 дней в неделю, не более 8 дней в месяц**.

Для обратной трансформации хронической мигрени в эпизодическую препарат, вызвавший ЛИГБ, отменяют полностью или частично: приём обезболивающих — **не более 2 дней в неделю (8 в месяц)**.

1. **амбулаторно** — отмена анальгетиков, антипиретиков и триптанов
2. **в стационаре или дневном стационаре** — отмена опиоидов, спазмолитиков, психотропных препаратов и анальгетиков в комбинации

В период отмены лечат «рикошетную» боль и другие симптомы отмены; препараты первого выбора — кортикостероиды системного действия, НПВП, противорвотные и анксиолитики.

1. #преднизолон: 100 мг 5 дней или 60 мг с постепенным снижением на 5–10 мг каждые 3 дня в течение 1–2 недель
2. #метилпреднизолон: 500 мг внутривенно или 125 мг в 250 мл раствора натрия хлорида с #диазепамом 10 мг и эзомепразолом 40 мг внутривенно капельно 1 раз в сутки 5 дней
3. #дексаметазон: 8 мг внутривенно капельно 1 раз в сутки 5 дней
4. #целекоксиб: 400 мг в сутки внутрь 5 дней, затем снижение на 100 мг каждые 5 дней
5. метоклопрамид при рвоте: 10 мг 1 раз в сутки внутрь или внутримышечно 5–7 дней

Детоксикацию проводят **в первые 2 недели** отмены; можно применять препараты тех классов, которыми пациент не злоупотреблял. С кортикостероидами и НПВП добавляют ингибиторы протонного насоса.

Для профилактики частой эпизодической и хронической мигрени с ЛИГБ применяют топирамат (100 мг/сут, диапазон 50–200 мг, титрация с 25 мг по 25 мг в неделю), ботулинический токсин типа А (155–195 ЕД по протоколу PREEMPT) и моноклональные антитела к CGRP; профилактику предпочтительно начинать одновременно с отменой.

4.5 Немедикаментозное лечение

Фармакологическое лечение сочетают с немедикаментозными методами для повышения эффективности терапии.

При тревожно-депрессивных и соматоформных расстройствах — когнитивно-поведенческая терапия, психотерапия и психологическая релаксация (УУР А).

Биологическая обратная связь по частоте пульса и электромиографии мышц скальпа и шеи — обучение психологическому и мышечному расслаблению (УУР А).

Рефлексотерапия (акупунктура) — дополнительный метод профилактического лечения (УУР В).

Постизометрическая релаксация — при выраженной дисфункции перикраниальных мышц (УУР А).

Лечебная физкультура (УУР В): упражнения лёгкой интенсивности, тренировки на выносливость, скандинавская ходьба — **максимум 3–4 раза в неделю** по 20–60 минут.

Блокада большого затылочного нерва кортикостероидами и местными анестетиками — дополнительный метод (УУР С).

Высокочастотная ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция — дополнительный метод профилактики, в том числе при хронической мигрени (УУР В).

Неинвазивная электростимуляция первой ветви тройничного нерва — для купирования приступов и профилактики (УУР А).

Инвазивная нейростимуляция большого затылочного нерва — при рефрактерной хронической мигрени; направление — совместно специалистом по головной боли и нейрохирургом (УУР А).

Диетотерапия не рекомендуется; целесообразен совет исключить продукты-провокаторы: шоколад, бананы, орехи, цитрусовые, жирные сыры, алкоголь.

4.6 Медицинская реабилитация

Реабилитация направлена на улучшение функционирования и качества жизни.

1. постизометрическая релаксация, лечебная физкультура, дыхательные упражнения;
2. массаж шеи, воротниковой зоны и спины;
3. рефлексотерапия;
4. коррекция осанки, эргономика рабочего места.

Профилактика эффективна, если число дней с болью **через 3 месяца** сокращается **на 50% и более**.

Дополнительно оценивают приём обезболивающих, коморбидные нарушения и работоспособность. Без улучшения, а также при тяжёлом течении (хроническая мигрень, множественные коморбидные нарушения, ЛИГБ) пациента направляют в специализированный центр лечения головной боли.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Всем пациентам показано динамическое наблюдение, в том числе с телефонными визитами.

1. разъяснение роли триггеров;
2. разъяснение факторов хронизации: стресса, депрессии, лекарственного абузуса, избытка кофеина, ожирения, синдрома апноэ во сне;
3. контроль эффективности и переносимости профилактики.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация в неврологическое отделение

1. головная боль с изменением сознания;
2. с лихорадкой и менингеальными симптомами;
3. с нарастающей очаговой неврологической симптоматикой;
4. с нарастающей общемозговой симптоматикой;
5. «громоподобная» головная боль;
6. мигренозный статус.

Плановая госпитализация

1. прогрессирующая головная боль;
2. некупируемая головная боль;
3. тяжёлая ЛИГБ при злоупотреблении опиоидами, спазмолитиками, психотропными препаратами и анальгетиками в комбинации;
4. атипичная аура **более 1 часа**.

Критерии выписки

1. купирование головной боли;
2. уменьшение боли **до 3–4 баллов по ВАШ**;
3. успешная замена препарата злоупотребления на адекватную терапию.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Мигрень»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	295_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Российское общество по изучению головной боли; Союз реабилитологов России
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.

Клинические рекомендации

Мигрень у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**G43.0** — Мигрень без ауры [простая мигрень] **G43.1** — Мигрень с аурой [классическая мигрень] **G43.2** — Мигренозный статус **G43.3** — Осложненная мигрень **G43.8** — Другая мигрень **G43.9** — Мигрень неуточненная **G44.0** — Синдром «гистаминовой» головной боли **G44.1** — Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках **G44.4** — Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Ассоциация Здоровье детей; Российское межрегиональное общество по изучению боли (РОИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/169_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Мигрень — первичная головная боль с повторяющимися приступами, которые часто сопровождаются тошнотой, рвотой, фото- и фонофобией; у детей боль чаще двусторонняя. Приступ длится от **1 часа (до 6 лет)** — **2 часов (старше 7 лет)** до нескольких суток и обычно прекращается со сном.
- Диагноз ставят исключительно клинически по критериям МКГБ-3; лабораторные и инструментальные исследования при типичной картине и нормальном неврологическом статусе не рекомендуются. МРТ головного мозга показана при редких формах ауры, осложнениях мигрени и «сигналах опасности».
- Для оториноларинголога: доброкачественное пароксизмальное головокружение детского возраста — эпизодический синдром, сочетающийся с мигренью; при мигрени со стволовой аурой возможны головокружение, шум в ушах, гипакузия.
- Приступ купируют ибупрофеном или парацетамолом в самом начале; обезболивающие **не более 2 (максимум 3) раз в неделю**. Триптаны в России разрешены **с 18 лет**, до 18 лет — с осторожностью по решению врачебной комиссии. Профилактическое лечение рассматривают при **2 и более приступах в месяц**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Мигрень (М) — одна из наиболее распространённых форм первичной головной боли, проявляющаяся повторяющимися приступами, которые часто сопровождаются тошнотой, рвотой, фото- и фонофобией.

Боль чаще односторонняя (гемикрания), сторона может меняться; у детей часто двусторонняя. Боль интенсивная и усиливается при лёгкой физической нагрузке.

Приступ длится от 1 часа **у детей до 6 лет** и от 2 часов **у детей старше 7 лет** до нескольких суток; обычно прекращается с наступлением сна.

2.2 Этиология и эпидемиология

Большое значение имеют наследственные факторы: моногенные формы — семейная гемиплегическая мигрень I–III типов (гены CACNA1A, ATP1A2, SCN1A) — встречаются крайне редко (0,01%); в большинстве случаев наследуется предрасположенность.

Мигрень считается нейроваскулярной головной болью: распространяющаяся волна корковой депрессии активирует тригеминоваскулярную систему с выбросом CGRP и нейрогенным воспалением.

Триггеры приступа

1. **психологические** — стрессы, эмоции, изменения настроения
2. **гормональные** — менструация, овуляция
3. **окружающая среда** — яркий свет, громкий шум, резкие запахи, погодные условия
4. **питание** — горький шоколад, твёрдые сыры, помидоры, киви, орехи, лук, чеснок, алкоголь, продукты с глутаматом, нитритами и нитратами, сладкие газированные напитки
5. **лекарства** — резерпин, нитроглицерин, эстрогены
6. **другие** — недосыпание или пересыпание, голод и нерегулярное питание, гипогликемия, гипертермия, усталость, авиаперелёты

В 7 лет распространённость мигрени — 1,2–3,2%, в 7–11 лет — 4–11%, у детей старше 11 лет и подростков — 8–23%; в 15–19 лет — около 28%.

2.3 Классификация

Классификация мигрени (МКГБ-3, 2018)

1. мигрень без ауры;
2. мигрень с аурой: с типичной аурой, со стволовой аурой, гемиплегическая (семейная, спорадическая), ретинальная;
3. хроническая мигрень;
4. осложнения мигрени: мигренозный статус, персистирующая аура без инфаркта, мигренозный инфаркт, аура — триггер эпилептического припадка;
5. возможная мигрень;
6. эпизодические синдромы, которые могут сочетаться с мигренью: синдром циклических рвот, абдоминальная мигрень, доброкачественное пароксизмальное головокружение, доброкачественный пароксизмальный тортиколлис.

2.4 Клиническая картина

Мигрень без ауры — приступы цефалгии продолжительностью **4–72 часа** (у детей от 2 часов) со специфическими сопровождающими симптомами; наблюдается примерно у половины больных мигренью.

Диагностические критерии мигрени без ауры (МКГБ-3)

1. A. Не менее 5 приступов, отвечающих критериям B–D.
2. B. Продолжительность **4–72 часа** (**у детей до 15 лет — 2–48 часов**) без лечения или при его неэффективности.
3. C. Не менее 2 признаков: односторонняя локализация; пульсирующий характер; средняя или значительная интенсивность; ухудшение от обычной физической активности.
4. D. Не менее 1 симптома: тошнота и/или рвота; фотофобия и одновременно фонофобия.

Мигрень с аурой характеризуется повторяющимися эпизодами обратимых локальных неврологических симптомов, которые нарастают **в течение 5–20 минут** и продолжаются **не более 60 минут**; за аурой, как правило, следует головная боль.

Диагностические критерии мигрени с аурой (МКГБ-3)

1. A. Не менее 2 приступов, отвечающих критериям B–D.
2. B. Хотя бы один полностью обратимый симптом ауры без двигательной слабости: зрительный, чувствительный, нарушение речи.
3. C. Не менее 2 признаков: гомонимные зрительные или односторонние чувствительные симптомы; постепенное развитие или последовательное возникновение симптомов **не менее 5 минут**; каждый симптом длится **от 5 до 60 минут**.
4. D. Головная боль, соответствующая мигрени без ауры, начинается во время ауры или **в течение 60 минут** после её начала.

1. **ретинальная мигрень** — повторяющиеся монокулярные расстройства зрения (мерцание, скотома, слепота) с мигренозной болью; исключают невропатию зрительного нерва, расслоение сонной артерии, патологию центральной артерии сетчатки
2. **гемиплегическая мигрень** — помимо ауры — полностью обратимая мышечная слабость
3. **мигрень со стволовой аурой** — не менее 2 симптомов: дизартрия, головокружение, шум в ушах, гипакузия, диплопия, атаксия, нарушение уровня сознания

1. **хроническая мигрень** — приступы **не менее 15 дней в месяц** на протяжении **не менее 3 месяцев** при эпизодической мигрени в анамнезе
2. **мигренозный статус** — приступ или серия приступов **более 72 часов** (исключая сон); как правило, показание к госпитализации
3. **персистирующая аура без инфаркта** — симптомы ауры **более 7 дней** без инфаркта по нейровизуализации
4. **мигренозный инфаркт** — стойкая неврологическая симптоматика, аура **более 60 минут**, инфаркт подтверждён нейровизуализацией

В детском возрасте относительно часто отмечаются эпизодические синдромы — нередко предшественники классической мигрени в старшем возрасте.

1. **синдром циклических рвот** — не менее 5 стереотипных приступов интенсивной тошноты и рвоты (не реже 4 раз в час, **от 1 часа до 10 дней**), интервал **не менее 1 недели**, между приступами ЖКТ без нарушений

1. **абдоминальная мигрень** — не менее 5 приступов боли в животе по средней линии, умеренной или сильной, с анорексией, тошнотой, рвотой, бледностью, **2–72 часа**; головная боль не характерна

1. **доброкачественный пароксизмальный тортиколлис** — приступы с повышенной возбудимостью, недомоганием, рвотой, атаксией; как правило, ежемесячно

Доброкачественное пароксизмальное головокружение — повторяющиеся кратковременные приступы головокружения у здоровых детей, возникающие спонтанно и проходящие самостоятельно.

Диагностические критерии (МКГБ-3)

1. A. Не менее 5 приступов, соответствующих критериям B и C.
2. B. Головокружение возникает спонтанно, максимально выражено в начале и проходит самостоятельно через минуты или часы, без потери сознания.
3. C. Не менее 1 признака: нистагм, атаксия, рвота, бледность, ощущение боязни.
4. D. Между приступами нет патологии в неврологическом статусе, при аудиометрии и исследовании вестибулярной функции.
5. E. Нет другого заболевания со сходной картиной.

Маленькие дети не могут описать головокружение: эпизоды нарушения равновесия, замеченные родителями, могут быть его проявлением. Должны быть исключены опухоли задней черепной ямки, эпилептические пароксизмы, заболевания вестибулярной системы.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз основан на жалобах пациента и родителей, анамнезе, неврологическом осмотре и исключении других причин головной боли; клиническая картина должна соответствовать критериям МКГБ-3.

1. **достоверный диагноз** — соответствие всем критериям мигрени с аурой или без ауры
2. **вероятный диагноз** — несоответствие по одному критерию
3. **возможный диагноз** — несоответствие по нескольким критериям

3.2 Жалобы и анамнез

Детям с головной болью проводится тщательный сбор анамнеза, общеклиническое и неврологическое обследование.

Предвестники приступа (за несколько часов или дней)

1. эмоциональные нарушения: раздражительность, депрессия, апатия;
2. нарушение сна;
3. изменения аппетита;
4. жажда и задержка жидкости.

У большинства детей с мигренью без ауры приступы — **1 раз в 1–2 месяца**, при мигрени с аурой реже, при гемиплегической — 1 раз в 4–6 месяцев.

У детей боль бывает давящей, распирающей или ломящей и локализуется в лобной, лобно-височной или периорбитальной области. У дошкольников она, как правило, двусторонняя, у старших детей — односторонняя со сменой сторон; только к 10–12 годам характеристики соответствуют взрослым.

Во время приступа характерны бледность, скудная мимика, тошнота, реже рвота, после которой ребёнок обычно засыпает; после сна приступ купируется. Приступ длится в среднем 2–3 часа без ауры и около часа с аурой. Между приступами дети практически здоровы.

3.3 Физикальное обследование

Интенсивность боли в приступе у пациентов **с 7 лет** оценивают по визуальной аналоговой шкале (ВАШ); у младших — по шкалам с изображением лиц или цветов.

Обычно боль достигает 7–9 баллов. Нередко отмечаются общая гиперестезия, фото- и фонофобия, особая чувствительность к запахам и прикосновениям.

3.4 Лабораторные исследования

Лабораторные исследования для диагностики мигрени не рекомендуются.

Для исключения мигренеподобной боли при метаболических расстройствах определяют гомоцистеин, витамин B12, фолиевую кислоту, лактат и пируват сыворотки крови.

3.5 Нейровизуализация и ЭЭГ

При соответствии критериям и нормальном неврологическом статусе инструментальные исследования не рекомендуются.

ЭЭГ при типичной картине без подозрения на эпилептический генез не рекомендуется.

При редких формах ауры (ретинальная, пролонгированная, стволовая) и осложнениях мигрени показаны МРТ головного мозга и МР-ангиография — для исключения аномалий развития сосудов головного мозга.

При нетипичном течении или «сигналах опасности» показаны МРТ, МР-ангиография или КТ головного мозга.

«Сигналы опасности»

1. головная боль, изменившая течение;
2. «громоподобная» боль, нарастающая до 10 баллов по ВАШ **за 1–2 секунды**;
3. строго односторонняя боль;
4. прогрессивно ухудшающаяся боль без ремиссий;
5. внезапная, необычная для пациента боль;
6. атипичная аура: необычные нарушения и/или продолжительность **более 1 часа**;
7. изменения сознания или психические нарушения;
8. очаговые симптомы и симптомы системного заболевания при впервые возникшей боли;
9. признаки внутричерепной гипертензии;
10. отёк диска зрительного нерва;
11. ВИЧ-инфекция, онкологическое, эндокринное, системное заболевание или травма головы в анамнезе;
12. неэффективность адекватного лечения;
13. очаговая симптоматика в неврологическом статусе;
14. нарастающая боль с тошнотой или рвотой, усиливающаяся при изменении положения головы.

Негрубые сосудистые аномалии, изменения белого вещества, арахноидальные и эпифизарные кисты клинического значения у детей с головной болью не имеют, но требуют разъяснений семье. Если родители связывают начало боли с травмой шеи, показана МР-ангиография сосудов головы и шеи для исключения диссекции сонной артерии; при признаках внутричерепной гипертензии исключают тромбоз венозных синусов.

При подозрении на эпилептический генез — короткий приступ после сна с тошнотой и однократной рвотой, кратковременные вегетативные или зрительные нарушения, ночная боль с последующей вялостью — показана ЭЭГ с видеомониторингом, в том числе во сне.

Детям с головной болью проводится офтальмоскопия для исключения застойных явлений на глазном дне; их выявление — показание к МРТ или КТ головного мозга.

3.6 Дневник головной боли и дифференциальная диагностика

Ведётся дневник головной боли: длительность и интенсивность, сопутствующие симптомы, триггеры, приём лекарств.

Главная задача — разграничить первичную и вторичную головную боль.

1. размер и форма головы: субкомпенсированная гидроцефалия сопровождается частыми болями;
2. острое начало нередко связано с системными инфекциями (ОРВИ, грипп, менингит) и органическим поражением мозга;
3. повторяющиеся приступы без нарастания и без изменений неврологического статуса указывают на первичную боль, в том числе мигрень;
4. головная боль напряжения отличается лёгкой или умеренной двусторонней давящей болью, не усиливающейся при нагрузке.

---

4. Лечение

Выделяют лечение приступа и профилактическое лечение. Дети часто пропускают начало приступа, поэтому детей и родителей обучают раннему распознаванию приступа и его лечению.

4.1 Купирование приступа

При приступах умеренной и высокой интенсивности применяется ибупрофен в самом начале приступа; у старших детей в исследованиях применялась доза 7,5 мг/кг.

1. дети: 10 мг/кг на приём

Парацетамол применяется в самом начале приступа.

1. дети: 10–15 мг/кг на приём
2. повторно: **через 6–8 часов**

При частых приступах обезболивающие **более 2 (максимум 3) раз в неделю** не рекомендуются из-за риска лекарственного абузуса.

При приступах умеренной интенсивности назначают НПВП (ибупрофен, парацетамол), при тяжёлых приступах (более 8 баллов по ВАШ) и неэффективности НПВП — триптаны или эрготамин в комбинации, исключая психолептики. Триптаны в России разрешены **с 18 лет**.

До 18 лет триптаны применяют с осторожностью при неэффективности других препаратов по решению врачебной комиссии с информированным согласием. Эффективность пероральных триптанов у детей однозначно не доказана, назальные формы эффективнее.

1. #суматриптан, масса **менее 40 кг**: 12,5–25 мг на приём
2. #суматриптан, масса **более 40 кг**: 50–100 мг
3. #золмитриптан (таблетки, назальный спрей 2,5 мг/доза): 2,5 мг при массе менее 40 кг, 5 мг — более 40 кг
4. #ризатриптан: 5 мг при массе менее 40 кг, 10 мг — более 40 кг

При выраженной тошноте и многократной рвоте в стационаре применяется #метоклопрамид внутривенно.

1. дети: 0,1 (0,13–0,15) мг/кг, максимум 10 мг

4.2 Немедикаментозное лечение

Всем пациентам с мигренью

1. режим сна;
2. регулярная оздоровительная спортивная нагрузка;
3. режим питания, достаточный объём жидкости, исключение пищевых провокаторов;
4. поведенческая терапия и психотерапевтическая коррекция: когнитивно-поведенческая терапия, биологическая обратная связь, релаксационные методы.

Когнитивно-поведенческая терапия включает психологическое консультирование, релаксационные тренинги, управление образом жизни и приверженность медикаментозной терапии.

Из дополнительных методов применяют биологическую обратную связь по электромиографическому или электроэнцефалографическому сигналу, общий массаж, иглорефлексотерапию.

4.3 Профилактическое лечение

Показания к профилактическому лечению

1. **2 и более** приступа мигрени в месяц;
2. тяжёлые и длительные приступы;
3. низкая эффективность купирующей терапии;
4. противопоказания или плохая переносимость препаратов для купирования;
5. необычная аура, пугающая ребёнка и родителей.

Изменение режима дня и образа жизни — всем пациентам

1. устранение или избегание триггеров;
2. релаксационная терапия;
3. гигиена сна;
4. исключение провоцирующих продуктов и уменьшение кофеинсодержащих напитков;
5. регулярная физическая нагрузка — **20–30 минут в день**.

Во время приступа рекомендуется отдых в затемнённой комнате; сон часто купирует приступ.

Всем пациентам показано динамическое наблюдение невролога по месту жительства.

Для профилактики у детей и подростков рекомендуются противоэпилептические препараты (наибольшее число исследований — по топирамату и вальпроевой кислоте). Минимальная продолжительность курса — **3 месяца**.

#Топирамат внутрь; при повышении дозы нарастают снижение аппетита и массы тела, парестезии, замедление когнитивных процессов, повышение образования солей в моче.

1. стартовая доза: 25 мг/сут
2. титрация: медленно в течение 8–10 недель до 2–3 мг/кг в сутки, максимум 100–200 мг/сут
3. курс: **не менее 3 месяцев**

#Вальпроевая кислота внутрь с медленной титрацией под контролем биохимических показателей функции печени и почек.

1. дети: 15–45 мг/кг/сут, эффективная доза 500–1000 мг/сут
2. минимальный курс: **3 месяца**

#Леветирацетам внутрь с постепенной титрацией.

1. целевая доза: 50 мг/кг/сут
2. масса **до 50 кг**: начало с 20 мг/кг/сут в 2 приёма, повышение на 10 мг/кг каждые 2 недели
3. масса **более 50 кг**: начало с 1000 мг/сут в 2 приёма, повышение на 500 мг 2 раза в сутки каждые 2–4 недели
4. длительность: **не менее 3 месяцев**

#Пропранолол внутрь под контролем частоты сердечных сокращений и артериального давления; противопоказан при бронхиальной астме, с осторожностью — при сахарном диабете, ортостатической гипотензии, депрессии.

1. начальная доза: 1 мг/кг/сут в 3 приёма
2. максимум: 4 мг/кг/сут
3. длительность: **не менее 3 месяцев**

#Циннаризин внутрь, лучше начинать с меньшей дозы; противопоказан при синдроме слабости синусового узла, АВ-блокаде 2–3 степени, сердечной недостаточности.

1. масса **менее 30 кг**: 1,5 мг/кг/сут
2. масса **более 30 кг**: 50 мг/сут
3. длительность: **не менее 3 месяцев**

#Амитриптилин внутрь на ночь; перед назначением — ЭКГ с физической нагрузкой. В последнее время применяется преимущественно при тяжёлом течении и хронической мигрени.

1. начальная доза: 0,25 мг/кг в сутки
2. повышение: **каждые 2 недели** до оптимальной 1 мг/кг/сут
3. длительность: **не менее 3 месяцев**

В качестве дополнительного лечения при низкой эффективности фармакотерапии применяют #рибофлавин 400 мг в день и #убидекаренон 150–300 мг в день курсом **2 месяца**.

Эффективна комбинация фармакологического и нефармакологического лечения (например, #амитриптилина с когнитивно-поведенческой терапией при хронической мигрени в 10–17 лет). Учитывают коморбидные тревожные и депрессивные расстройства.

Для предотвращения лекарственно-индуцированной головной боли простые анальгетики и НПВП ограничивают **не более 14 раз в месяц**, триптаны и сочетания триптанов с НПВП — **до 9 раз в месяц**.

Эффект оценивают по дневнику: снижение частоты приступов **на 50%** от исходного считается положительным эффектом профилактической терапии.

4.4 Медицинская реабилитация

При частых приступах и тяжёлом течении рекомендуется санаторно-курортное лечение **1–2 раза в год**: грязевые аппликации на воротниковую зону, радоновые или сероводородные ванны, лечебная физкультура, массаж.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация в неврологическое отделение

1. головная боль с изменением сознания;
2. головная боль с лихорадкой и менингеальными симптомами;
3. нарастающая очаговая неврологическая симптоматика;
4. нарастающая общемозговая симптоматика;
5. мигренозный статус.

Плановая госпитализация

1. прогрессирующая головная боль;
2. некупируемая головная боль;
3. головная боль с аурой.

Критерии выписки

1. купирование головной боли;
2. уменьшение боли **до 3–4 баллов по ВАШ**.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Мигрень»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 15.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	169_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Российское межрегиональное общество по изучению боли; Ассоциация «Здоровье детей»
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Доза #топирамата: в тексте рекомендации — старт 25 мг/сут с титрацией до 2–3 мг/кг в сутки и максимумом 100–200 мг/сут, а в таблице 3 — «1–2 мг/кг/сутки (12,5–25 мг/сутки)». На странице приведена доза из рекомендации.

Клинические рекомендации

Множественные переломы мозгового и лицевого черепа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S02.0** — Перелом свода черепа **S02.1** — Перелом основания черепа **S02.4** — Перелом скуловой кости и верхней челюсти **S02.6** — Перелом нижней челюсти **S02.7** — Множественные переломы черепа и лицевых костей **S02.8** — Переломы других лицевых костей и костей черепа **S02.9** — Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей **S07** — Размозжение головы
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Ассоциация травматологов-ортопедов России; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Всероссийское Общество по детской нейрохирургии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/871_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Черепно-лицевая травма — повреждение мозгового отдела черепа и (или) головного мозга в сочетании с травмой лицевого отдела черепа. При подозрении на перелом черепа показана экстренная госпитализация в специализированный стационар.
- Первоочередные задачи на месте: восстановление дыхания (асфиксия при переломах челюстей), остановка кровотечения, транспортная иммобилизация, экстренная доставка в стационар.
- Базальная ликворея — признак перелома основания черепа. Её отличают от отделяемого из носа по глюкозе и специфическим маркерам (beta-2 transferrin); фистулу закрывают хирургически при неэффективности консервативной терапии в течение **5–7 дней**, в том числе эндоназально эндоскопически.
- При кровотечении из носа с угрозой аспирации выполняют интубацию или вводят S-образный воздуховод и проводят переднюю и заднюю тампонаду носа; при профузных рецидивирующих носовых кровотечениях показаны эндоваскулярная эмболизация или эндоназальная перевязка (коагуляция) крылонёбной артерии.
- В стационаре выполняют МСКТ головного мозга и лицевого отдела черепа и назначают консультации нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, офтальмолога и оториноларинголога.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Множественная травма — травма, в результате которой возникло два и более повреждения мягких тканей и (или) костей в пределах одной анатомической области.

Черепно-лицевая (краниофациальная) травма — повреждения мозгового отдела черепа и (или) головного мозга в сочетании с травмой лицевого отдела черепа.

Перелом костей основания черепа — повреждение основания черепа с нарушением его анатомической целостности и функциональными расстройствами; к ним относятся переломы глазничной поверхности лобной кости, пирамиды височной кости, решётчатой пластинки, клиновидной кости, затылочной кости с переходом на большое затылочное отверстие.

Вдавленный перелом черепа — перелом, при котором фрагменты кости смещаются более чем на толщину прилежащей кости.

Повреждения средней зоны лица чаще всего множественные и сочетанные. При одновременном повреждении костей носа, решётчатой кости и других костей средней зоны их объединяют понятием травмы средней зоны лица. Сочетанные повреждения вызывают «синдром взаимного отягощения».

2.2 Этиология и эпидемиология

Переломы лицевого черепа составляют 3–4% травм с повреждением костей: нижняя челюсть — 65,1%, скуловая кость и дуга — 12,8%, кости носа — 3,8%, верхняя челюсть — 2,0%. Причинами являются ДТП, падения с высоты, реже производственная и спортивная травма. Переломы челюстей в пределах зубного ряда считаются заведомо открытыми.

Переломы основания черепа составляют 4% тяжёлых ЧМТ; у 32–59% линия перелома переходит со свода на основание. Летальность при сочетанной черепно-лицевой травме у детей — 7,1–22%.

2.3 Классификация

Локализация переломов по зонам лица

1. **верхняя зона лица**: передняя стенка лобной пазухи, крыша глазницы
2. **средняя зона лица**: назоэтмоидальный комплекс, кости носа, скулоорбитальный комплекс, верхняя челюсть по верхнему, среднему и нижнему уровню, альвеолярный отросток
3. **нижняя зона лица**: нижняя челюсть

Переломы костей носа рассматриваются в отдельных КР (оториноларингология), переломы орбиты — в офтальмологических; здесь они упоминаются только в составе множественных переломов.

Классификация черепно-лицевой травмы

1. **субкраниальные**: назоорбитальные и назомаксиллярные, центральные (Ле Фор I, II, Вассмунд I, II), центролатеральные (Ле Фор III, Вассмунд IV), латеральные (скуловая кость, дуга, скулоорбитальный комплекс)
2. **краниофациальные**: верхняя и средняя зоны лица с передней черепной ямкой; панфациальные: все зоны лица и основание черепа
3. **фронтофациальные**: передняя черепная ямка и верхняя зона: стенки лобной пазухи, верхний край и стенка орбиты, решётчатая пластинка, задние решётчатые ячейки, верхняя и латеральная стенки клиновидной пазухи

Из-за плотного прилегания твёрдой мозговой оболочки и сообщения с пазухами большинство переломов основания черепа рассматриваются как открытые проникающие; они возможны даже при незначительной травме.

2.4 Клиническая картина

Признаки перелома основания черепа

1. гипосмия или аносмия;
2. базальная ликворея;
3. глазодвигательные нарушения (III, IV, VI нервы), повреждение зрительного нерва;
4. одно- и двусторонние нарушения слуха, спонтанный нистагм;
5. при поперечном переломе пирамиды: выпадение слуха и вестибулярной функции, повреждение лицевого нерва.

Наружные признаки, указывающие на характер перелома

1. периорбитальная гематома (симптом «очков») **через 12–48 часов** указывает на перелом передней черепной ямки;
2. гематома в области сосцевидного отростка (симптом Бэттла), лагофтальм, асимметрия лица указывают на перелом пирамиды височной кости и парез лицевого нерва;
3. гемотимпанум или разрыв барабанной перепонки могут свидетельствовать о переломе основания черепа;
4. рино- или отоликворея указывает на перелом передней или средней черепной ямки;
5. эмфизема лица указывает на перелом лицевых костей, возможно дна передней черепной ямки;
6. экзофтальм с отёком конъюнктивы указывает на каротидно-кавернозное соустье или ретробульбарную гематому;
7. кровотечение из носа или ушей, нарушение слуха, нистагм, рвота.

Раннюю ликворею трудно распознать при сочетании с кровотечением; помогает проба со светлым ободком вокруг кровянистого пятна на марлевой салфетке.

Симптомы при повреждениях зон лица

1. **верхняя зона**: асимметрия, параорбитальные гематомы, симптом «лица панды» в первые часы, истинный симптом «очков» через сутки, затруднение носового дыхания, диплопия, эмфизема, кровотечение и (или) ликворея из носа
2. **средняя зона**: уплощение средней зоны, деформация носа, симптом «очков», затруднение носового дыхания, кровотечение и (или) ликворея из носа, подвижность фрагментов, нарушение прикуса и открывания рта
3. **нижняя зона**: симптом «ступеньки», патологическая подвижность фрагментов, симптом непрямой нагрузки, нарушение движений челюсти и прикуса

Симптомы множественных переломов лица малозаметны из-за отёка и кровоизлияний; даже при кровотечении и ликворее их не всегда вовремя диагностируют у тяжелопострадавших с явными повреждениями других областей.

---

3. Диагностика

3.1 Догоспитальный этап

Признаки перелома лицевых костей на догоспитальном этапе

1. деформация лица за счёт западения или отёка;
2. нарушение прикуса;
3. нарушение чувствительности в зоне подглазничного и (или) подбородочного нерва;
4. ограничение подвижности нижней челюсти;
5. патологическая подвижность и крепитация отломков, положительная проба непрямой нагрузки.

Восстановление дыхания

1. осмотр и санация полости рта: сгустки, осколки зубов, инородные тела;
2. при двустороннем переломе нижней челюсти: фиксация языка;
3. боковое стабильное положение;
4. при отёке, затрудняющем дыхание: S-образный воздуховод.

Асфиксия при челюстно-лицевых ранениях: дислокационная (40%), обтурационная (29%), стенотическая (23%), клапанная (5%), аспирационная (3%).

Кровотечение останавливают зажимом, тугой тампонадой раны, жгутом на шею через поднятую противоположную руку или пальцевым прижатием. Для транспортной иммобилизации применяют стандартную или теменно-подбородочную пращевидную повязку.

Очерёдность медицинской эвакуации

1. **первая очередь**: тяжёлое и крайне тяжёлое состояние: нарушение сознания, очаговая неврологическая симптоматика, продолжающееся кровотечение, ликворея, нарушение дыхания, тахикардия 100 и более, АД 100 мм рт. ст. и ниже, гемоглобин менее 100 г/л
2. **вторая очередь**: удовлетворительное или среднетяжёлое состояние с множественными повреждениями, подозрением на сотрясение мозга, возрастом **старше 60 лет**, сопутствующими заболеваниями
3. **третья очередь**: изолированная травма челюстно-лицевой области без неврологической симптоматики и кровотечения

3.2 Жалобы и анамнез

Анамнез собирают у пострадавшего, сопровождающих и из листа скорой помощи.

Что уточнить

1. механизм травмы, травмирующий предмет, время и место;
2. нарушение сознания и амнезию, их длительность;
3. прививку от столбняка, аллергию, сопутствующие заболевания;
4. лечение до поступления и его результат.

3.3 Осмотр, пальпация и перкуссия

Всем пациентам показаны оценка общего состояния, осмотр, пальпация и перкуссия челюстно-лицевой области; при осмотре выявляют признаки перелома черепа, следы кровотечения, истечения ликвора или детрита из раны.

Что отметить при осмотре

1. деформацию и симметричность лица, отёк, гематомы, раны, эмфизему;
2. движения глазных яблок, межкантальное расстояние;
3. кровотечение или ликворею из носа, уплощение средней зоны лица;
4. зоны нарушения чувствительности;
5. открывание рта, прикус, болезненность при перкуссии зубов.

При кровотечении и переломах основания и лицевого отдела черепа с угрозой аспирации показаны срочная интубация трахеи или S-образный воздуховод; кровотечение останавливают механически, выполняя переднюю и заднюю тампонаду носа и ротоглотки.

Высокий риск осложнений: асфиксия, анемия, бронхолёгочные гнойные заболевания, синуситы, внутричерепные гнойные осложнения, травматический остеомиелит, посттравматическая деформация.

Тяжесть состояния оценивают нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, анестезиолог-реаниматолог, при сочетанной травме — травматолог и хирург.

3.4 Анализы крови и мочи

Всем пациентам показаны лабораторные исследования для оценки тяжести (общий анализ крови и мочи и др.); при ЧМТ следует руководствоваться рекомендациями «Очаговая травма головного мозга» и «Черепно-мозговая травма у детей».

3.5 Компьютерная томография

В стационаре выполняют МСКТ; всем пациентам с подозрением на перелом черепа при поступлении проводят КТ головного мозга. При необходимости применяют конусно-лучевую КТ, особенно для средней зоны лица.

ЛОР-структуры при МСКТ

1. верхнечелюстные пазухи: положение, симметричность, гемосинус, повреждение стенок;
2. решётчатые ячейки, лобные и клиновидная пазухи;
3. кости носа, перегородка, носовые раковины, сошник.

Поиск ликворной фистулы

1. КТ с толщиной срезов 1–3 мм и коронарной реконструкцией: решётчатая пластинка, стенки решётчатых ячеек, верхняя стенка клиновидной пазухи, крыша барабанной полости;
2. аксиальные срезы: задняя стенка лобной пазухи, стенки клиновидной пазухи, ячейки сосцевидного отростка;
3. визуализация самой фистулы: КТ-цистернография.

По показаниям выполняют МРТ головного мозга и лицевого черепа (кровоизлияния, эмфизема в тканях глазницы); КТ-ангиографию проводят при вдавленном переломе над крупными венозными синусами.

При отсутствии КТ выполняют рентгенографию черепа как минимум в 2 проекциях.

3.6 Исследование ликвора и отделяемого из носа

Спинномозговую пункцию выполняют при подозрении на интракраниальные гнойные осложнения и отсутствии признаков дислокации.

При подозрении на базальную ликворею исследуют глюкозу в отделяемом из носа и уха. В ликворе глюкозы больше (2,3–4,0 ммоль/л), а белка меньше (0,10–0,22 г/л), чем в серозном отделяемом.

Специфические маркеры ликвора — beta-2 transferrin (есть только в ликворе) и beta-trace protein (в ликворе 18,4 мг/л, в крови 0,59 мг/л).

3.7 Консультации специалистов

Для исключения ЧМТ, повреждения ЛОР-органов и органа зрения показаны МСКТ и консультации специалистов:

1. нейрохирург (при его отсутствии — невролог);
2. челюстно-лицевой хирург;
3. офтальмолог;
4. оториноларинголог;
5. детский стоматолог.

При подозрении на повреждение внутренних органов — хирург, травматолог, реаниматолог.

---

4. Лечение

План лечения составляет челюстно-лицевой хирург совместно с нейрохирургом; офтальмолог, оториноларинголог, травматолог привлекаются по характеру травмы. Часто приоритетны нейрохирургические операции. Решающим фактором исхода является время от травмы до специализированного лечения.

4.1 Консервативное лечение

При отсутствии показаний к операции лечение проводится в соответствии с тяжестью ЧМТ. С консервативной терапии начинают в двух ситуациях.

Посттравматический парез лицевого нерва при переломе височной кости

1. глюкокортикоиды;
2. вазодилататоры;
3. физиотерапия.

Базальная ликворея

1. постельный режим в положении полусидя;
2. серия люмбальных пункций или наружный люмбальный дренаж;
3. дегидратационная терапия.

4.2 Сроки репозиции и иммобилизации отломков

Репозицию и фиксацию отломков целесообразно отложить до стабилизации: при тяжёлом состоянии — через **2–7 суток и более**, после противошоковых мероприятий. Первичную хирургическую обработку ран проводят как можно раньше; глухой шов — до **24–36 часов** после травмы.

Сроки иммобилизации по сочетанию ЧМТ и переломов лица

1. тяжёлая ЧМТ и тяжёлые переломы лица: временная иммобилизация после выведения из шока, лечебная: **на 2–5-е сутки**, остеосинтез **не ранее 7-х суток**;
2. тяжёлая ЧМТ и нетяжёлые переломы лица: лечебная иммобилизация **через 1–3 суток**;
3. нетяжёлая ЧМТ и тяжёлые переломы лица: иммобилизация и остеосинтез **в первые сутки**;
4. нетяжёлая ЧМТ и нетяжёлые переломы: **в первые часы**.

4.3 Ортопедическое лечение

У детей основным является ортопедический метод; иммобилизацию выполняют индивидуальными проволочными, ленточными или пластмассовыми назубными шинами.

При ЧМТ с позывами на рвоту, особенно у детей, назубные шины и межчелюстную тягу в первые **2–3 суток** лучше не накладывать из-за риска аспирации и асфиксии; возможна шина без межчелюстной фиксации.

Переломы нижней челюсти у детей со сформированным постоянным прикусом (**после 12–13 лет**): ортопедическая иммобилизация назубными проволочными (стандартными ленточными) шинами с межчелюстной эластичной тягой.

4.4 Хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению

1. невозможность репонировать смещённые фрагменты ортопедическими методами из-за значительного смещения или при многооскольчатых переломах;
2. недостаточное число устойчивых зубов для стабильной ортопедической фиксации фрагментов челюсти;
3. интерпозиция мягких тканей в щели перелома;
4. переломы скуловорбитального, скулоназоорбитального, скулоназоэтмоидального комплексов, стенок орбиты, стенок лобной пазухи;
5. проникающий вдавленный перелом (раневая ликворея, выделение детрита, пневмоцефалия);
6. активное кровотечение из раны, сильное загрязнение раны, раневая инфекция;
7. истечение ликвора через нос, не останавливающееся консервативными методами;
8. отсутствие эффекта консервативного лечения или отсроченный парез лицевого нерва;
9. отсроченное ухудшение зрения при повреждении зрительного нерва в канале;
10. сдавление мозга, «растущий перелом», косметически значимая деформация.

Противопоказания

1. декомпенсированная соматическая патология;
2. острая ЧМТ тяжёлой и крайне тяжёлой степени, реже средней;
3. травматический или геморрагический шок с нестабильной гемодинамикой.

Основным методом является остеосинтез пластинами и винтами для черепно-лицевой хирургии. Детям нерассасывающиеся пластины после консолидации обязательно удаляют.

Доступы к средней зоне: коронарный, трансконъюнктивальный, субцилиарный, транскутанный по нижнему краю глазницы, трансоральный, трансантральный (гайморотомия), по Лимбергу.

Операции при переломах черепа

1. удаление внутричерепных гематом, декомпрессивная трепанация;
2. закрытие базальной ликворной фистулы при неэффективности консервативной терапии **5–7 дней** — транскраниально или эндоназально эндоскопически;
3. декомпрессия лицевого нерва через среднюю черепную ямку или транслабиринтно;
4. декомпрессия зрительного нерва;
5. эндоваскулярные вмешательства при ложных аневризмах, соустьях и профузных рецидивирующих носовых кровотечениях; перевязка или коагуляция крылонёбной артерии эндоназальным доступом;
6. репозиция вдавленного перелома у детей элеватором.

При переломе черепа рекомендуется раннее хирургическое вмешательство; при вдавленном переломе давностью до суток без загрязнения раны — репозиция отломков или первичная пластика дефекта.

У младенцев и детей младшего возраста при вдавленных или растущих переломах для восстановления твёрдой мозговой оболочки и костей свода черепа используют только аутоткань: апоневроз, надкостницу, расщеплённую кость, рёбра.

4.5 Антибактериальная профилактика

Всем пациентам, которым планируется операция, показана периоперационная антибиотикопрофилактика: разовая терапевтическая доза за **30–60 минут** до разреза, как правило однократно; при продлении: отмена не позднее **24 часов** после операции.

Препараты в зависимости от доступа

1. наружный доступ без сообщения с полостью рта: цефазолин или цефуроксим;
2. внутриротовой доступ, сообщение с полостью рта, открытый перелом: цефазолин или цефуроксим + метронидазол либо амоксициллин + клавулановая кислота;
3. аллергия на бета-лактамы, риск MRSA — ванкомицин (за 120 минут до разреза).

Доза цефазолина у детей после 3 лет

1. масса тела до 80 кг: 1 г;
2. масса тела 80 кг и более: 2 г.

Если продолжительность операции превышает 2 периода полувыведения препарата, вводится дополнительная разовая доза.

4.6 Антибактериальная терапия

Показания

1. рана IV типа («инфицированная»): старая травма, предшествующая инфекция, гнойное отделяемое, нежизнеспособные ткани.

Ориентируются на терапевтические дозы по инструкции с учётом массы тела, возраста, функции почек и печени.

Амоксициллин + клавулановая кислота внутривенно

1. взрослые и подростки старше 12 лет: 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки, максимальная суточная доза 6 г;
2. дети до 12 лет: 25 мг/кг в сутки;
3. длительность: до 14 дней.

Цефазолин

1. дети: 25 мг/кг/сут, в тяжёлых случаях до 100 мг/кг/сут;
2. дети до 1 месяца: противопоказан;
3. длительность: 7–10 дней.

Метронидазол внутривенно капельно

1. дети до 12 лет: 7,5 мг/кг на введение;
2. дети старше 12 лет: 500 мг на введение.

Цефуроксим

1. дети, включая грудных: 30–100 мг/кг/сут в 3–4 введения;
2. новорождённые и дети до 3 месяцев: 30 мг/кг/сут в 2–3 введения.

Ванкомицин только внутривенно

1. взрослые и дети старше 12 лет: 2 г в сутки (0,5 г каждые 6 часов или 1 г каждые 12 часов);
2. дети от 1 месяца до 12 лет: 10 мг/кг каждые 6 часов, суточная доза 40 мг/кг;
3. новорождённые: начальная доза 15 мг/кг, затем 10 мг/кг каждые 12 часов на 1-й неделе жизни, со 2-й недели — каждые 8 часов до возраста 1 месяца.

Показания к антибиотикотерапии в послеоперационном периоде

1. загрязнение раны инородными телами;
2. пластика вдавленного перелома протезом;
3. нагноившиеся раны головы.

При нагноении раны

1. снятие швов, ревизия раны, вторичная хирургическая обработка;
2. удаление титановых или иных пластических материалов;
3. вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом или абсцесса полости рта;
4. посев гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы;
5. продолжение этиотропной терапии, местное лечение.

4.7 Обезболивание и иное лечение

Остеосинтез выполняется под общим обезболиванием с интубацией через нос или рот, ортопедические манипуляции — под премедикацией и местной анестезией.

При нарушении всех компонентов приёма пищи питание осуществляют через зонд, при неэффективности — парентерально. Детям **до 3 лет** назначают молочную диету, старше — челюстную. Физиотерапию назначает физиотерапевт.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация в отделение челюстно-лицевой хирургии

1. подозрение на перелом челюсти любой локализации или его наличие;
2. раны мягких тканей лица и полости рта;
3. обширные раны мягких тканей челюстно-лицевой области.

Пострадавших с множественными переломами госпитализируют в многопрофильный стационар с нейрохирургией и нейрореанимацией, круглосуточной КТ; при транспортировке — временная иммобилизация челюстей. Плановой госпитализации нет.

Показания к выписке

1. выполнены запланированные исследования;
2. восстановлена анатомическая целостность челюстно-лицевой области;
3. нет признаков послеоперационных осложнений.

5.2 Медицинская реабилитация

Всем пациентам с множественными переломами черепа и сочетанной ЧМТ после иммобилизации костных фрагментов показаны реабилитационные мероприятия для полного физического и социального восстановления.

5.3 Диспансерное наблюдение

Детям диспансеризация проводится на весь период до завершения роста лицевых костей. Осмотры назначают **через 2–4 недели**, 3, 6 месяцев и год.

Участники наблюдения

1. челюстно-лицевой хирург;
2. невролог и офтальмолог;
3. оториноларинголог;
4. ортодонт и детский стоматолог.

После выписки пациента наблюдает невролог **1 раз в 3 месяца** в первый год, затем **1 раз в 6 месяцев**, поскольку возможны посттравматическая эпилепсия, гидроцефалия, ликворея.

Обследование на 1-м году диспансерного наблюдения

1. КТ головного мозга;
2. электроэнцефалография;
3. консультация невролога;
4. консультация офтальмолога.

Через **4 недели** после операции проводят контрольное рентгенологическое исследование для оценки консолидации фрагментов и исключения посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Множественные переломы мозгового и лицевого отделов черепа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 24.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года

Код в рубрикаторе	871_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 7 при делении на группы перелом верхней челюсти по Ле Фор I и II отнесён к тяжёлым переломам лица (1-я группа), а Ле Фор III (черепно-лицевое разъединение) — к нетяжёлым (2-я группа); от группы зависят сроки иммобилизации.

Клинические рекомендации

Наружные отиты

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H60.0** — Абсцесс наружного уха **H60.1** — Целлюлит наружного уха **H60.2** — Злокачественный наружный отит **H60.3** — Другие инфекционные наружные отиты **H60.4** — Холестеатома наружного уха **H60.5** — Острый наружный отит неинфекционный **H60.8** — Другие наружные отиты **H60.9** — Наружный отит неуточненный **H61.0** — Перихондрит наружного уха **H61.8** — Другие уточненные болезни наружного уха **H61.9** — Болезнь наружного уха неуточненная **H62.0** — Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.1** — Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.3** — Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.4** — Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.8** — Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 13.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/663_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Наружный отит является воспалительным поражением ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.
- При неосложнённом наружном отите:
  1. местно ушные капли; при бактериальном отите препараты первого выбора: фторхинолоны;
  2. туалет наружного слухового прохода;
  3. обезболивание.
- При неосложнённом отите системная антибактериальная терапия не показана. Показания к системным антибиотикам:
  1. постлучевой отит;
  2. сахарный диабет;
  3. иммуносупрессия;
  4. хондроперихондрит.
- Эффективность терапии оценивают **через 48–72 часа**. При отсутствии эффекта уточняют диагноз и исключают атопический или контактный дерматит, псориаз, экзему.
- Диагноз злокачественного наружного отита устанавливается только при наличии всех основных критериев (перечень — во вкладке «Диагностика»).

  При злокачественном наружном отите необходимы

  1. определение уровня глюкозы крови;
  2. компьютерная томография (КТ);
  3. госпитализация;
  4. системная антибактериальная терапия **не менее 6 недель**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Наружный отит характеризуется воспалительными изменениями ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.

Наиболее часто выделяют острую и хроническую (продолжительностью **более 6–12 недель**) формы наружного отита. Разновидность определяется локализацией и характером воспалительного процесса: различают диффузный и ограниченный наружный отит.

Нозологические формы диффузного наружного отита

1. экзема;
2. дерматит;
3. рожистое воспаление;
4. герпес;
5. перихондрит, хондроперихондрит;
6. злокачественный наружный отит и ряд других видов.

Нозологические формы ограниченного наружного отита

1. фурункул;
2. абсцесс.

Развитию воспаления предшествует нарушение целостности кожи, которое могут вызвать:

1. травматическое повреждение;
2. длительное пребывание во влажной среде;
3. изменения кожи на фоне нарушения обмена веществ, сахарного диабета;
4. дерматит или экзематозный процесс.

Предрасполагающие факторы

1. узкий наружный слуховой проход, экзостозы;
2. ношение слухового аппарата;
3. попадание воды в уши;
4. недостаточное образование и изменение состава ушной серы;
5. нарушение местного и общего иммунного статуса;
6. лучевое воздействие.

2.2 Жалобы

Жалобы

1. дискомфорт и боль в ухе, нередко усиливающаяся при надавливании и жевании, с иррадиацией в глаз, зубы, глотку;
2. снижение слуха при полной обтурации слухового прохода;
3. в ряде случаев зуд и выделения из уха.

Системные проявления

1. лихорадка, как правило субфебрильная;
2. ухудшение самочувствия (явления инфекционного токсикоза).

2.3 Физикальное обследование

Признаки при осмотре

1. гиперемия, отёк, инфильтрация и лихенификация кожи наружного слухового прохода, в ряде случаев ушной раковины и поверхностного слоя барабанной перепонки;
2. патологическое отделяемое;
3. при ограниченной форме абсцессы и инфильтраты в наружном слуховом проходе и других отделах наружного уха;
4. регионарный лимфаденит: увеличение, уплотнение, болезненность околоушных, передне- и заднешейных лимфатических узлов.

2.4 Особенности клинических форм

При фурункуле наружного слухового прохода в стадии инфильтрации ведущей жалобой является дискомфорт, усиливающийся при манипуляциях в ухе, в стадии абсцедирования на первый план выходит боль. При диффузном отите беспокоят боль, выделения из уха, возможно снижение слуха.

При экзематозном отите определяются желтовато-розовые очаги с шелушением, беспокоит зуд, в ряде случаев интенсивный и предшествующий высыпаниям. В дальнейшем образуются микровезикулы, эрозии, участки мокнутия, причём элементы разных стадий наблюдаются одновременно.

При герпетическом поражении за 1–2 суток до высыпаний возникают жжение, зуд и покалывание, затем появляются эритема, пузырьки и корочки. Как правило, процесс разрешается за 10–14 дней, а при присоединении вторичной инфекции в течение 3–4 недель.

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании характерных жалоб и клинической картины; при необходимости его подтверждают лабораторными и другими методами исследования.

3.1 Бактериологическое, микологическое и цитологическое исследования

Выполняют

1. бактериологическое исследование отделяемого;
2. микроскопическое и культуральное исследование на грибы;
3. цитологическое исследование;
4. при подозрении на новообразование: биопсию.

Забор материала

1. до начала противомикробной терапии;
2. под контролем отоскопии;
3. тампоном диаметром до 0,3 см из просвета или со стенок наружного слухового прохода, без контакта с его наружными отделами.

Резистентность возбудителей и возможное наличие грибковой флоры требуют микробиологического исследования с последующим подбором терапии по спектру возбудителей и их чувствительности.

3.2 Аудиометрия

Показания

1. жалобы на снижение слуха после купирования воспаления; цель исследования — исключить острую нейросенсорную тугоухость.

При неосложнённых формах, не распространяющихся на среднее и внутреннее ухо, возможна кондуктивная тугоухость.

3.3 Компьютерная и магнитно-резонансная томография

Показания к КТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ)

1. осложнённая форма: формирование костных секвестров, абсцессов.

При неосложнённом отите необходимости в лучевой диагностике нет.

3.4 Консультация профильного специалиста

Показания

1. поражение наружного уха на фоне системного, в том числе инфекционного, заболевания: консультация профильного специалиста и дообследование.

3.5 Злокачественный наружный отит

Диагноз злокачественного наружного отита устанавливается при наличии всех основных критериев.

Основные критерии

1. боль в ухе и головная боль на стороне поражения;
2. отёк стенок наружного слухового прохода;
3. выделения из уха;
4. грануляции в слуховом проходе;
5. микроабсцессы в области уха и основания черепа;
6. очаг воспаления по данным сцинтиграфии;
7. отсутствие эффекта от лечения **более недели**;
8. синегнойная палочка при посеве.

Дополнительные критерии

1. сахарный диабет;
2. поражение черепных нервов;
3. истощение;
4. пожилой возраст.

При невозможности выполнить сцинтиграфию назначают местное лечение **на 1–3 недели**; отсутствие улучшения свидетельствует в пользу злокачественного отита.

При злокачественном наружном отите показано определение уровня глюкозы крови, поскольку в 90–100% случаев он сочетается с сахарным диабетом.

---

4. Лечение

Основа лечения:

1. устранение предрасполагающих факторов;
2. адекватное обезболивание;
3. регулярный туалет наружного слухового прохода.

4.1 Неосложнённый наружный отит: местное лечение

Для местного лечения неосложнённого наружного отита используют препараты, активные в отношении золотистого стафилококка и синегнойной палочки. Эффективность оценивают **через 48–72 часа**. Сохранение симптомов требует уточнения диагноза и исключения атопического или контактного дерматита, псориаза, экземы.

При бактериальном наружном отите препаратами первого выбора являются ушные капли с фторхинолонами.

Ушные капли показаны всем пациентам с бактериальным наружным отитом; препараты перечислены в таблице ниже.

При всех формах наружного отита применяют антисептики и (или) противомикробные препараты:

1. антисептики: бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид, йод с калия йодидом и поливиниловым спиртом;
2. противомикробные препараты: фторхинолоны, аминогликозиды, противогрибковые препараты.

На фоне местного лечения к 7–10-м суткам выздоравливают 65–95% пациентов.

При экзематозной форме применяют кортикостероиды в сочетании с противомикробными средствами.

Ушные капли

Препарат	Состав	Возраст
Офлоксацин	офлоксацин	с 1 года
Ципрофлоксацин + дексаметазон (в КР под названием «Комбинил»)	ципрофлоксацин (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	с 18 лет
Норфлоксацин	норфлоксацин	с 15 лет
Рифамицин	рифамицин	без ограничений
Лидокаин + неомицин + полимиксин В	неомицин + полимиксин В (антибактериальный компонент), лидокаин (местный анестетик)	с 1 года
Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол	хлорамфеникол (антибактериальный компонент), клотримазол (противогрибковый компонент), беклометазон (противовоспалительный компонент), лидокаин (местный анестетик)	с 6 лет
Дексаметазон + неомицин + полимиксин В	неомицин + полимиксин В (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	без ограничений
Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон	фрамицетин + грамицидин (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	без ограничений

> В этой рекомендации капли с норфлоксацином разрешены с 15 лет, тогда как в КР «Отит средний острый» детям старше 1 года. Возрастное ограничение следует сверить с инструкцией в ГРЛС.

4.2 Системная антибактериальная терапия

При неосложнённом наружном отите системная антибактериальная терапия не показана, поскольку её добавление к местному лечению не улучшает результатов.

Показания к системной антибактериальной терапии:

1. постлучевой наружный отит;
2. сахарный диабет;
3. иммуносупрессия.

При хондроперихондрите ушной раковины применяют системные антибиотики и противовоспалительные средства для купирования болевого синдрома и отёка.

4.3 Злокачественный наружный отит

Системная антибактериальная терапия продолжительностью **не менее 6 недель** препаратами с антисинегнойной и антистафилококковой активностью.

4.4 Хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению

1. фурункул наружного слухового прохода **в стадии абсцедирования**;
2. гнойный хондроперихондрит ушной раковины;
3. пролежень кожи наружного слухового прохода;
4. злокачественный (некротический) наружный отит.

Объём вмешательства

1. ограниченный отит: вскрытие и дренирование абсцессов наружного слухового прохода;
2. злокачественный отит: удаление грануляций, костных и хрящевых секвестров и холестеатомы в пределах зоны поражения.

4.5 Физиотерапия

Для повышения эффективности лечения применяется физиотерапия.

Микробиологическое исследование повторяется до подтверждения элиминации возбудителя.

При сахарном диабете и нарушении толерантности к глюкозе необходим контроль уровня глюкозы крови.

---

5. Профилактика. Показания к госпитализации

Профилактика

1. ограничить использование ватных палочек;
2. избегать избыточного туалета наружного слухового прохода;
3. соблюдать гигиену при использовании берушей, слуховых аппаратов и наушников.

Лечение, как правило, амбулаторное.

Показания к госпитализации

1. некротический (злокачественный) наружный отит.

Критерии выписки

1. стихание воспалительных явлений в наружном слуховом проходе;
2. отсутствие гнойно-септических осложнений.

Медицинская реабилитация не рекомендована.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наружные отиты»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 13.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее ноября 2027
Код в рубрикаторе	663_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые. Для детей — отдельная КР «Наружный отит» (21_3)

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Ушные капли с норфлоксацином в данной рекомендации разрешены с 15 лет, в КР «Отит средний острый» детям старше 1 года.

Клинические рекомендации

Наружный отит у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H60.0** — Абсцесс наружного уха **H60.1** — Целлюлит наружного уха **H60.2** — Злокачественный наружный отит **H60.3** — Другие инфекционные наружные отиты **H60.5** — Острый наружный отит неинфекционный **H60.8** — Другие наружные отиты **H60.9** — Наружный отит неуточненный **H61.0** — Перихондрит наружного уха **H61.8** — Другие уточненные болезни наружного уха **H61.9** — Болезнь наружного уха неуточненная **H62.0** — Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.1** — Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.2** — Наружный отит при микозах **H62.3** — Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.4** — Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.8** — Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/21_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Наружный отит: воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки. Формы по течению:
  1. острая: **до 6 недель**;
  2. хроническая: симптомы **более 3 месяцев** или **более 4 эпизодов в год**.
- Критерии диагноза:

  Обязательный критерий

  1. признаки воспаления слухового прохода: болезненный козелок и (или) ушная раковина, или диффузный отёк, или гиперемия слухового прохода.

  Возможные признаки

  1. оторея;
  2. регионарная аденопатия;
  3. эритема барабанной перепонки или целлюлит ушной раковины и прилегающей кожи;
  4. боль в ухе, иногда с иррадиацией в челюсть;
  5. зуд или ощущение распирания в ухе.
- Основу лечения составляет местная терапия ушными каплями, активными против синегнойной палочки и золотистого стафилококка. Эффект оценивают **через 48–72 часа**, курс в среднем **7–10 дней** (до 14).
- При неосложнённом наружном отите системные антибактериальные препараты не назначают: они неэффективны.
- Лечение, как правило, амбулаторное. Госпитализации подлежат дети в тяжёлом состоянии; неэффективность лечения, подозрение на прогрессирование и осложнения требуют консультации оториноларинголога и госпитализации.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Наружный отит (НО): воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода (НСП) и эпидермального слоя барабанной перепонки.

2.2 Классификация

По течению

1. острая форма: **до 6 недель**;
2. хроническая форма: симптомы сохраняются **более 3 месяцев** или **более 4 эпизодов** наружного отита в год.

Нозологические формы

1. диффузный наружный отит;
2. ограниченный наружный отит: фурункул, абсцесс;
3. экзема и дерматит;
4. рожистое воспаление;
5. перихондрит;
6. герпетическое поражение;
7. грибковый наружный отит;
8. злокачественный наружный отит.

Злокачественный наружный отит (ЗНО): наиболее тяжёлая форма, для которой характерно быстро прогрессирующее течение с распространением процесса за пределы ушной раковины, слухового прохода и наружного уха.

2.3 Этиология

Воспалению предшествует нарушение целостности кожи.

Причины и предрасполагающие факторы

1. травматические повреждения;
2. длительное пребывание во влажной среде, попадание воды в уши;
3. изменения кожи при нарушении обмена веществ, сахарном диабете, дерматитах, экземе;
4. узкие наружные слуховые проходы, экзостозы;
5. ношение слухового аппарата, наушников;
6. недостаточное образование или изменение состава ушной серы;
7. нарушение местного и общего иммунного статуса;
8. лучевое воздействие.

Ведущие возбудители у детей: синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus); также P. vulgaris и E. coli.

Частота бактериальной природы и выделения возбудителей

1. воспалительные заболевания наружного уха имеют бактериальную природу в 60–98%;
2. P. aeruginosa выделяют в 20–60%, S. aureus в 10–70%;
3. анаэробные штаммы встречаются в 4–25%;
4. смешанная флора — в трети случаев.

Грибковый наружный отит у детей не редкость: в России более 20% поражений наружного уха. Основные возбудители: плесневые грибы Aspergillus и Penicillium, дрожжеподобные грибы Candida. Часто выделяют грибково-бактериальные ассоциации с синегнойной палочкой, стрептококками и стафилококками.

Факторы развития микоза

1. травматическое повреждение кожи;
2. нарушение обмена веществ и гормонального баланса;
3. иммунодефицит;
4. длительное применение системных антибактериальных препаратов и кортикостероидов.

2.4 Клиническая картина

Диффузный наружный отит, острая форма.

Отоскопия

1. отёк и гиперемия кожи НСП, выделения вязкого секрета;
2. барабанная перепонка может быть не видна из-за отёка стенок слухового прохода в хрящевом и костном отделах;
3. детрит в НСП.

Симптомы

1. болезненность в области НСП, усиливается при оттягивании ушной раковины или надавливании на козелок;
2. возможна лихорадка до фебрильных цифр;
3. болезненность и ограничение движений в височно-нижнечелюстном суставе при открывании рта;
4. увеличение и болезненность заушных лимфатических узлов («псевдомастоидит»).

Хроническая фаза: утолщение кожи из-за инфильтрации или фиброза, миринги т. Кондуктивное снижение слуха при значительном сужении или обтурации слухового прохода отделяемым.

Фурункул слухового прохода (ограниченный наружный отит).

Отоскопия

1. сужение просвета очерченным конусовидным или округлым возвышением с локальной гиперемией;
2. стадия инфильтрации (**1–3-и сутки**): локальное уплотнение кожи;
3. стадия абсцедирования: просвечивающая гнойная головка;
4. после самопроизвольного вскрытия: кратерообразное углубление с гноем.

Симптомы

1. боль в ухе, усиливается при оттягивании раковины или надавливании на козелок;
2. иррадиация в зубы, глаз, шею, околоушную область, глотку;
3. инфильтрация может распространяться на мягкие ткани, сосцевидный отросток и веки;
4. фурункул задней стенки: возможны кашель и рвота (раздражение ветвей блуждающего нерва);
5. фурункул передней или нижней стенки: воспаление околоушной железы;
6. увеличенные, плотные, болезненные регионарные лимфатические узлы;
7. возможна фебрильная лихорадка;
8. кондуктивное снижение слуха при значительном сужении слухового прохода.

Экзема и дерматиты.

Острая экзема

1. гиперемия и инфильтрация кожи раковины и НСП;
2. везикулёзно-пустулёзная сыпь на отёчном основании, мокнутие, серо-жёлтые корки;
3. выраженный зуд;
4. вторичная инфекция ведёт к ограниченному или диффузному наружному отиту.

Хроническая экзема

1. зуд;
2. утолщение кожи;
3. шелушение, трещины, мокнутие.

Рожистое воспаление.

1. выраженная гиперемия и припухлость кожи раковины, включая мочку, с линией демаркации за пределами раковины;
2. жжение и резкая болезненность при пальпации;
3. интоксикация (озноб, головная боль), лихорадка **до 39–40 °C**;
4. при буллёзной форме пузыри с серозным содержимым.

Перихондрит ушной раковины: мочка уха не вовлечена.

1. выраженная боль в раковине с возможной иррадиацией в голову или шею;
2. отёк, гиперемия, сглаженность контуров раковины;
3. резкая болезненность при пальпации;
4. гной между надхрящницей и хрящом, флюктуация;
5. интоксикация;
6. при позднем обращении расплавление хряща, свищи и рубцовая деформация раковины.

Герпетическое поражение.

1. множественные сгруппированные пузырьки на раковине, в НСП, иногда на барабанной перепонке; после вскрытия корочки;
2. резкая боль, покалывание, зуд;
3. возможна интоксикация;
4. в тяжёлых случаях нейросенсорная тугоухость, нарушение равновесия, парез лицевого и тройничного нервов.

Грибковое поражение: картина зависит от возбудителя.

1. грудные и ясельные дети: беспокойство, маятникообразные движения головы, расчёсы кожи раковин;
2. старшие дети: жидкие выделения (при кандидозе), корочки, зуд, боль, заложенность и снижение слуха; редко головная боль, лихорадка, чувствительность раковины и заушной области.

Возбудитель	Картина
Candida	1. гиперемия, инфильтрация и мацерация кожи НСП, гиперемия барабанной перепонки; 2. отделяемое менее густое, беловатое; 3. на раковине гиперемия с эрозиями, легко снимающиеся беловатые налёты; 4. возможен хондроперихондрит с деформацией раковины.
Aspergillus	1. казеозно-некротические массы в просвете; 2. инфильтрация сильнее в костном отделе, возможен мирингит; 3. беловато-серые наложения с чёрными вкраплениями («молотый перец»); 4. Aspergillus glaucus: зеленоватое отделяемое.
Penicillium	1. желтоватое отделяемое, иногда похоже на серу, по всему слуховому проходу; 2. инфильтрация кожи, сухие корочки и плёнки.
Geotrichum capitatum	1. выраженная инфильтрация кожи НСП, мирингит; 2. плотные «замазкообразные» серовато-жёлтые массы по всему слуховому проходу.

Злокачественный (некротизирующий) наружный отит у детей редок, возможен при иммунодефиците, в том числе при лейкозе после трансплантации костного мозга.

1. интенсивная боль в ухе, головная боль на стороне поражения;
2. системные признаки: интоксикация или лихорадка;
3. возможны болезненность височной кости и парез лицевого нерва;
4. классический симптом: грануляции в костно-хрящевом соединении дна НСП;
5. инфекция распространяется к основанию черепа с остеомиелитом височной кости.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании анамнеза и физикального обследования с отоскопией. Другие исследования необходимы для выбора лечения, диагностики осложнений и динамического контроля.

3.1 Жалобы

Местные

1. боль в ухе, может усиливаться при пальпации и жевании;
2. зуд в НСП;
3. выделения из уха;
4. снижение слуха.

Системные

1. лихорадка, как правило субфебрильная;
2. ухудшение самочувствия (инфекционный токсикоз).

3.2 Отоскопия

Показания

1. все пациенты с подозрением на наружный отит.

Диагностические признаки

1. болезненность при нажатии на козелок и оттягивании ушной раковины;
2. НСП гиперемирован, как правило сужен отёком;
3. барабанная перепонка видна частично, возможна умеренная гиперемия;
4. при отопневмоскопии подвижность барабанной перепонки, как правило, сохранена.

3.3 Микробиологическое исследование отделяемого из уха

Показания

1. тяжёлое течение: до начала терапии;
2. рецидивирующий и хронический наружный отит;
3. иммунодефицит: иммунодепрессанты, ВИЧ-инфекция, химио- или лучевая терапия;
4. инфекция после операции на ухе;
5. нет ответа на начальную терапию.

Посев на аэробы и факультативные анаэробы с определением чувствительности, микроскопия и посев на дрожжевые и мицелиальные грибы.

Забор материала

1. до начала антимикробной терапии;
2. под зрительным контролем;
3. тонким стерильным зондом-тампоном из просвета или со стенок НСП, не касаясь дистальных отделов наружного уха.

При необходимости контроля или без эффекта исследование повторяют.

3.4 Анализы крови

Рутинно не проводят: лабораторных исследований, подтверждающих диагноз, нет.

Показания

1. все госпитализированные, в том числе со злокачественным наружным отитом: развёрнутый общий анализ крови и С-реактивный белок.

3.5 Рентгенография или КТ височной кости

Показания

1. подозрение на злокачественный наружный отит или деструктивный процесс: рентгенография или КТ височных костей, при необходимости с контрастированием.

Диагностические признаки

1. деструкция височной кости и основания черепа для наружного отита не характерна, кроме злокачественного.

3.6 МРТ височных костей и основания черепа

Показания

1. подозрение на распространение воспаления на окружающие мягкие ткани: уточнение диагноза, распространённости и тактики.

Наркоз по показаниям.

3.7 Консультации специалистов

При поражении наружного уха на фоне системных, в том числе инфекционных, заболеваний показаны консультация профильного специалиста и обследование по соответствующим КР. Консультацию проводит:

1. детский онколог;
2. инфекционист;
3. аллерголог-иммунолог;
4. детский эндокринолог;
5. невролог;
6. дерматовенеролог.

3.8 Дифференциальная диагностика

Проводят всем с подозрением на наружный отит, в том числе при оторее.

Заболевание	Отличия от наружного отита
Средний отит	1. перфорация барабанной перепонки: диагноз наружного отита сомнителен, вероятен очаг в среднем ухе со вторичным воспалением НСП.
Мастоидит	1. сглаженность заушной складки; 2. изменения больше в заушной области, в проекции антрума; 3. на рентгенограмме или КТ: снижение воздушности, нарушение структуры и целостности клеток сосцевидного отростка.
Гнойный паротит	1. припухлость и болезненность книзу и кпереди от НСП (проекция околоушной железы); 2. обильное гноетечение из уха при прорыве абсцесса через санториниевы щели.
Отомикоз	1. налёты и наложения на коже НСП: тёмный налёт как угольная пыль или «мокрая газетная бумага» (Aspergillus niger), белесоватые хлопья (Candida albicans); 2. предрасполагают влажность и микротравмы, может быть осложнением антибактериальной терапии; 3. подтверждается микробиологическим исследованием.

Особенно важно дифференцировать **злокачественный наружный отит**.

Признаки злокачественного наружного отита

1. грануляции в слуховом проходе;
2. микроабсцессы в области наружного уха и основания черепа;
3. костная деструкция по лучевым методам;
4. нет эффекта консервативной терапии **более одной недели**.

Отягощающие факторы

1. сахарный диабет;
2. нейропатии черепных нервов;
3. истощение.

Отсутствие положительной динамики **в течение 1–3 недель** свидетельствует в пользу ЗНО.
Подтверждение: КТ или МРТ (остеомиелит основания черепа), дополнительно маркеры воспаления: нейтрофильный лейкоцитоз, повышение С-реактивного белка.

---

4. Лечение

4.1 Неосложнённый наружный отит

Местная терапия

Всем пациентам с установленным наружным отитом назначают ушные препараты: противомикробные, кортикостероиды, их комбинации, анальгетики и анестетики.

Препарат должен действовать на синегнойную палочку и золотистый стафилококк. Эффект оценивают **через 48–72 часа**, длительность лечения в среднем **7–10 дней** (до 14).

Препараты из таблицы предназначены для начальной местной терапии неосложнённого наружного отита: безопасны и эффективны, осложнения практически не возникают.

Местная терапия создаёт оптимальную концентрацию в очаге, почти не всасывается и реже ведёт к отбору устойчивых штаммов.

Препараты для местного лечения у детей

Препарат	Компоненты	Возрастные ограничения
Офлоксацин, капли глазные и ушные	антибактериальный: офлоксацин	с 12 лет; с 1 года при тимпаностомической трубке
Ципрофлоксацин, капли глазные и ушные	антибактериальный: ципрофлоксацин	с рождения (с 0 лет)
Норфлоксацин, капли глазные и ушные	антибактериальный: норфлоксацин	с 1 года
Ципрофлоксацин + дексаметазон (Комбинил), капли глазные и ушные	антибактериальный: ципрофлоксацин; противовоспалительный: дексаметазон	с 1 года
Бетаметазон + гентамицин, капли глазные и ушные	антибактериальный: гентамицин; противовоспалительный: бетаметазон	с 8 лет

Препарат	Компоненты	Возрастные ограничения
Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон, капли глазные и ушные	антибактериальный: грамицидин + фрамицетин; противовоспалительный: дексаметазон	с 1 года
Дексаметазон + неомицин + полимиксин В, капли ушные	антибактериальный: полимиксин В + неомицин; противовоспалительный: дексаметазон	нет ограничений
Лидокаин + неомицин + полимиксин В, капли ушные	антибактериальный: полимиксин В + неомицин; анестезирующий: лидокаин	нет ограничений; детям до 1 года только при крайней необходимости и под контролем врача
Рифамицин, капли ушные	антибактериальный: рифамицин	нет ограничений
Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол, капли ушные	антибактериальный: хлорамфеникол; противогрибковый: клотримазол; противовоспалительный: беклометазон; анестезирующий: лидокаин	с 6 лет
Миконазол, крем 2% [2]	противогрибковый: миконазол	нет ограничений
Клотримазол, крем 1% [1] [2]	противогрибковый: клотримазол	нет ограничений
Натамицин, крем 2%	противогрибковый: натамицин	нет ограничений

[1] Клотримазол не активен в отношении Aspergillus. [2] Курс **не менее 10 дней**.

Наружный отит как проявление контактного, атопического или себорейного дерматита, псориаза, системной красной волчанки: лечение по соответствующим КР. При себорейном дерматите возможна инфекция грибами Malassezia: нужна местная противогрибковая и (или) противовоспалительная терапия.

Возможны аллергические реакции на местное лечение, в том числе на препараты с неомицином.

Туалет наружного слухового прохода

Слуховой проход регулярно и атравматично очищают от серы и экссудата у всех пациентов: экссудат снижает эффективность местного лечения.

Туалет обычно проводит оториноларинголог. После исключения дефекта барабанной перепонки слуховой проход можно осторожно промывать дистиллированной водой или 0,9% раствором натрия хлорида. Ватные палочки применять не следует: микротравмы способствуют инфекции.

Обезболивание

Показания

1. выраженный болевой синдром.

Системно ибупрофен или парацетамол в возрастных дозах и (или) местное обезболивание. Ибупрофен в суспензии разрешён **с 3 месяцев**, у парацетамола есть ограничения для детей младшего возраста. Местное обезболивание может замаскировать прогрессирование: такого пациента наблюдают **48 часов**.

Устранение предрасполагающих факторов ускоряет разрешение воспаления (см. «Этиология»).

4.2 Системная антибактериальная терапия

При неосложнённом наружном отите системная антибактериальная терапия не показана: результаты местного лечения в сочетании с системными антибиотиками и с плацебо не различаются.

Показания

1. воспаление вышло за пределы НСП: заушный абсцесс, мастоидит;
2. острый средний отит, в том числе у детей младшего возраста;
3. постлучевой наружный отит;
4. злокачественный (некротизирующий) отит;
5. неконтролируемый сахарный диабет;
6. иммуносупрессия;
7. невозможность местной антибактериальной терапии.

Препарат должен действовать на P. aeruginosa и S. aureus.

4.3 Грибковый наружный отит

Тщательный туалет НСП является обязательным условием местной противогрибковой терапии; его выполняют аттиковым зондом и ватником с противогрибковым препаратом.

Кандидозный отит: 1% раствор клотримазола или 1% раствор нафтифина

1. туалет и аппликации на турундах: 2 раза в сутки, экспозиция до 10 минут;
2. курс в среднем **4 недели**.

Плесневые и диморфные грибы: 1% раствор нафтифина

1. туалет и аппликации на турундах: 2 раза в сутки, экспозиция до 15 минут;
2. курс в среднем **4 недели**.

Противогрибковые кремы (миконазол, клотримазол, натамицин) и длительность их применения приведены в таблице «Препараты для местного лечения у детей» и в сносках к ней.

При перфорированной барабанной перепонке грибковое поражение расценивается как системная (инвазивная) инфекция: показан противогрибковый препарат системного действия по данным посева, например флуконазол при кандидозном и итраконазол при аспергиллёзном наружном отите, с учётом возрастных ограничений инструкции.

4.4 Злокачественный наружный отит

Доказательных данных о терапии недостаточно. До получения результатов посева применяют препараты, активные против синегнойной палочки.

1. #ципрофлоксацин внутрь: 20–30 мг/кг в сутки в 2 приёма каждые 12 часов, не более 1500 мг в сутки;
2. или парентерально в эквивалентной дозе: антисинегнойные пенициллины, цефалоспорины III или IV поколения с антисинегнойной активностью, с аминогликозидами или без, по чувствительности возбудителя.

Многие штаммы P. aeruginosa устойчивы к ципрофлоксацину из-за его широкого амбулаторного применения. При иной этиологии (Enterobacterales, Aspergillus и другие плесневые грибы, MRSA) назначают соответствующие системные противомикробные препараты.

Курс **4–6–8 недель**, при грибковой этиологии дольше, например **до 12 недель**.

Параллельно проводят местную терапию, возможно применение антисептиков и препаратов йода. При прогрессировании заболевания или плохом ответе на консервативное лечение показано хирургическое лечение, возможно в сочетании с гипербарической оксигенацией.

Во время лечения регулярно контролируют клинику и КТ или МРТ, чтобы оценить ответ и вовремя заметить возобновление; проводят контрольный посев отделяемого. Частота исследований индивидуальна.

4.5 Хирургическое лечение

Показания

1. устранение причины или осложнения наружного отита.

Вмешательства

1. вскрытие и дренирование абсцесса (флегмоны) НСП;
2. иссечение грануляций;
3. секвестрэктомия: удаление костных и хрящевых секвестров;
4. удаление холестеатомы НСП.

Объём в пределах зоны поражения; выполняет оториноларинголог с анестезиологом-реаниматологом.

4.6 Физиотерапия

Избирательно, как дополнительное лечение, применяют низкочастотное магнитное поле, низкоинтенсивное лазерное излучение эндоаурально, короткое ультрафиолетовое облучение наружного уха. Убедительных доказательств эффективности нет.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Лечение в большинстве случаев амбулаторное. При бактериальном наружном отите улучшение наступает **через 12–24 часа** после начала антибактериальной терапии.

Показания к госпитализации

1. тяжёлое состояние ребёнка;
2. неэффективность лечения;
3. подозрение на прогрессирование воспаления;
4. развитие осложнений.

При неэффективности, прогрессировании и осложнениях необходима консультация оториноларинголога, при злокачественном отите также детского онколога и других специалистов.

Злокачественный наружный отит требует стационарного лечения.

5.2 Критерии выписки

1. устойчивое купирование проявлений болезни;
2. отсутствие угрозы жизни и здоровью пациента.

Осложнения нелеченого или неадекватно леченого отита

1. переход в хроническую форму с обострениями при неблагоприятных факторах;
2. разрушение хрящевой и костной ткани НСП;
3. распространение на прилегающие ткани и органы.

5.3 Профилактика

Не допускать травм и переувлажнения НСП

1. периодически обрабатывать антисептиком наушники, ушные вкладыши слуховых аппаратов и беруши;
2. пользоваться только своими наушниками, вкладышами и берушами;
3. ограничить время в наушниках;
4. не использовать ватные палочки;
5. избегать жёстких многоразовых берушей;
6. высушивать слуховой проход после попадания воды, в том числе феном.

Детям **старше 2 лет**: своевременное удаление ушной серы как возможной причины острого наружного отита.

Медицинская реабилитация не требуется.

Диспансерное наблюдение не требуется.

Прогноз в большинстве случаев благоприятный.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наружный отит»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 18.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	21_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; МАКМАХ
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Наследственный ангиоотёк

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D84.1** — Дефект в системе комплемента
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 22.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Ассоциация медицинских генетиков; Национальная Ассоциация Экспертов в области Первичных Иммунодефицитов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/267_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Наследственный ангиоотёк — редкое, потенциально жизнеугрожающее генетически детерминированное заболевание: ангиоотёки кожи и слизистых оболочек под действием брадикинина, без зуда, гиперемии и крапивницы, без эффекта от системных глюкокортикостероидов и антигистаминных средств.
- **Ангиоотёк гортани**
  1. время от появления нарушения дыхания до асфиксии непредсказуемо, в среднем **20–40 минут**;
  2. при нарастании отёка или неэффективности терапии показана госпитализация в оториноларингологическое или реанимационное отделение;
  3. при признаках нарастающей обструкции — раннее проведение коникотомии, временной трахеостомии или интубации трахеи.
- **Купирование приступа**
  1. икатибант: 30 мг подкожно;
  2. ингибитор С1-эстеразы человека: 20 МЕ/кг внутривенно;
  3. свежезамороженная плазма: 400 мл внутривенно — только при отсутствии других препаратов.

  Системные глюкокортикостероиды, эпинефрин и антигистаминные средства для купирования не рекомендуются.
- Перед любыми оперативными вмешательствами, в том числе стоматологическими и в области дыхательных путей, проводится краткосрочная профилактика: ингибитор С1-эстеразы человека внутривенно **за 1–6 часов** до манипуляции. Ангиоотёк после процедур возникает, как правило, **в течение 48 часов**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Наследственный ангиоотёк (НАО) — редкое, потенциально жизнеугрожающее генетически детерминированное заболевание, проявляющееся в виде ангиоотёков кожи и слизистых/подслизистых оболочек, возникающих под воздействием брадикинина. Характерными особенностями ангиоотёков при НАО являются отсутствие зуда, гиперемии кожи, сопутствующей крапивницы, а также отсутствие эффекта от лечения кортикостероидами и антигистаминными средствами системного действия. НАО относится к первичным иммунодефицитам без инфекционных проявлений.

2.2 Этиология и эпидемиология

В основе НАО с дефицитом С1-ингибитора (I и II типа) лежит накопление брадикинина вследствие снижения синтеза С1-ингибитора и/или его функциональной активности. Наследование в абсолютном большинстве случаев аутосомно-доминантное; примерно у 20–25% пациентов заболевание обусловлено вновь возникшей мутацией, семейный анамнез отсутствует.

Распространённость НАО с дефицитом С1-ингибитора — 1:50 000; в России зарегистрировано 472 пациента.

2.3 Классификация

НАО с дефицитом С1-ингибитора

1. I тип — снижение количества и функциональной активности С1-ингибитора (85% случаев);
2. II тип — снижение функциональной активности при нормальном или повышенном уровне С1-ингибитора (15% случаев).

НАО с нормальным уровнем С1-ингибитора обусловлен мутациями в генах XII фактора свёртывания, плазминогена, ангиопоэтина 1, кининогена 1, миоферлина и др.; при типичной клинике и семейном анамнезе без выявленной мутации устанавливается НАО с неизвестной мутацией.

2.4 Клиническая картина

Характерен ранний дебют заболевания в первой или второй декаде жизни; у 25% пациентов семейный анамнез отсутствует. Ангиоотёки нечувствительны к системным антигистаминным средствам и глюкокортикостероидам.

1. рецидивирующие периферические ангиоотёки — практически у 100% пациентов, без крапивницы, нарастают медленно, длятся в среднем **2–4 суток**, чаще на конечностях;
2. абдоминальные атаки — более чем у 80%: от дискомфорта до острой боли в животе с рвотой, диареей, вздутием; часто становятся причиной необоснованного хирургического вмешательства.

Ангиоотёки, способные привести к асфиксии (жизнеугрожающие), — ангиоотёк гортани, языка, связочного аппарата и нёбной занавески. При отёке языка он существенно увеличивается в объёме и часто не помещается в ротовой полости.

Триггеры ангиоотёка

1. механическая травма: длительное сдавление, укол, ушиб, оперативные и стоматологические вмешательства, инвазивные обследования;
2. острые инфекции, декомпенсация сопутствующей патологии;
3. менструация, беременность, лактация;
4. приём эстрогенсодержащих препаратов, ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II;
5. стресс.

---

3. Диагностика

3.1 Настораживающие признаки

Настораживающие признаки НАО

1. рецидивирующие ангиоотёки, не купирующиеся системными глюкокортикостероидами и антигистаминными средствами (**сутки и более**);
2. повторные обращения по поводу «острого живота» без объективной причины, рецидивирующие асциты во время болевого синдрома;
3. сочетание ангиоотёков с приступами острой боли в животе;
4. отягощённый семейный анамнез, смерть родственника от асфиксии;
5. дебют или утяжеление ангиоотёков на фоне эстрогенов, ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II.

3.2 Физикальное обследование

Определяется характер отёка: ангиоотёк при НАО несимметричный, сохраняется **до 5 дней**, полностью проходит без следа.

Визуальное исследование верхних дыхательных путей показано при жалобах

1. ощущение отёка в горле;
2. нарушение дыхания и глотания;
3. осиплость голоса, дисфония;
4. страх смерти, стридор.

Наличие ангиоотёка должно быть подтверждено осмотром врача.

3.3 Лабораторные исследования

1. **НАО I типа** — уровень С1-ингибитора и его функциональная активность **менее 50%** от нормы
2. **НАО II типа** — снижение функциональной активности **более чем на 50%** при отсутствии значимого снижения уровня

Всем пациентам с подозрением на НАО показано двукратное исследование уровня и функциональной активности ингибитора С1-эстеразы (и/или молекулярно-генетическое исследование); изменённые показатели подтверждают с интервалом **не менее 1 месяца**.

Уровень С4 фракции комплемента используется для скрининга, но не для диагноза: он снижается при многих заболеваниях. Определение С2 и С3 не рекомендуется.

Всем родственникам пациента с НАО I и II типов, особенно детям, даже без клинических проявлений, проводится скрининговое обследование для своевременной диагностики.

У детей **до 1 года** уровни С1-ингибитора и его активности в норме ниже, чем у взрослых, поэтому эти показатели для диагностики неинформативны.

3.4 Консультации специалистов

При признаках отёка верхних дыхательных путей показан осмотр оториноларинголога, анестезиолога-реаниматолога и/или врача скорой медицинской помощи для объективизации жалоб и оценки проходимости дыхательных путей.

При подозрении на НАО показана консультация аллерголога-иммунолога с обследованием на дефекты системы комплемента; при установленном диагнозе — не реже 1 раза в год.

3.5 Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика

1. приобретённый ангиоотёк с дефицитом С1-ингибитора;
2. ангиоотёки на фоне ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов ангиотензина II;
3. ангиоотёки, вызванные медиаторами тучных клеток, идиопатические;
4. псевдоангиоотёки: гипопротеинемические отёки, синдром Мелькерссона — Розенталя, синдром верхней полой вены.

Ангиоотёк длится от часов до нескольких суток и проходит бесследно; если отёк сохраняется дольше, диагноз ангиоотёка маловероятен.

4. Лечение

4.1 Купирование ангиоотёков

При ангиоотёках, способных привести к асфиксии, абдоминальных атаках и периферических ангиоотёках с риском осложнений назначают препараты для купирования в максимально короткие сроки: икатибант (антагонист брадикининовых рецепторов 2 типа) или ингибитор С1-эстеразы человека (концентрат из донорской крови).

1. икатибант: взрослым 30 мг подкожно; детям с 2 лет — по массе тела, от 10 мг при 12–25 кг до 30 мг при массе более 65 кг;
2. ингибитор С1-эстеразы человека: 20 МЕ/кг внутривенно, детям с 2 лет — 20 МЕ/кг;
3. свежезамороженная плазма: взрослым 400 мл, детям 10 мл/кг внутривенно — только при отсутствии других опций.

Пациентов, в том числе на доклинической стадии, обеспечивают препаратами для купирования на дому — не менее чем на две атаки — и обучают самостоятельному введению: позднее назначение может привести к фатальному исходу при ангиоотёке верхних дыхательных путей.

Свежезамороженная плазма применяется только при отсутствии быстрого доступа к ингибитору С1-эстеразы и икатибанту: она не эквивалентна патогенетической терапии и сопряжена с риском трансмиссивных инфекций и нежелательных реакций, в том числе анафилактического шока.

Для купирования не рекомендуются

1. транексамовая кислота и даназол;
2. системные глюкокортикостероиды;
3. эпинефрин;
4. системные антигистаминные средства.

При ангиоотёке гортани с нарастанием отёка или неэффективностью терапии показана госпитализация в оториноларингологическое или реанимационное отделение; при признаках нарастающей обструкции дыхательных путей — раннее проведение коникотомии, временной трахеостомии или интубации трахеи.

4.2 Краткосрочная профилактика

Краткосрочную профилактику проводят перед любыми оперативными вмешательствами, в том числе малыми и стоматологическими, и перед инвазивными исследованиями, особенно в области дыхательных путей и верхних отделов пищеварительного тракта. Ангиоотёки после процедур обычно возникают **в течение 48 часов**.

1. ингибитор С1-эстеразы человека: взрослым 1000 МЕ, детям с 2 лет — 15–30 МЕ/кг внутривенно;
2. #даназол: взрослым 200–600 мг за 4 дня до и 4 дня после вмешательства;
3. свежезамороженная плазма: взрослым 400 мл, детям 10 мл/кг внутривенно — только при отсутствии ингибитора С1-эстеразы.

Препаратом выбора для краткосрочной профилактики является ингибитор С1-эстеразы человека; его вводят как можно ближе к началу процедуры — оптимально **за 1–6 часов** до манипуляции.

Системные глюкокортикостероиды и антигистаминные средства для подготовки к инвазивным вмешательствам не рекомендуются. Всех пациентов перед вмешательствами обеспечивают препаратами для купирования не менее двух атак: премедикация не исключает «прорывных» приступов.

4.3 Долгосрочная профилактика

Для долгосрочной профилактики НАО I и II типов используют пять групп препаратов: ланаделумаб (300 мг 1 раз в 2 недели), ингибитор С1-эстеразы человека, даназол, транексамовую кислоту, гестагены.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания к экстренной госпитализации

1. признаки компрессии дыхательных путей;
2. тяжёлая абдоминальная атака;
3. отсутствие или недостаточный эффект амбулаторного лечения при тяжёлом ангиоотёке или ангиоотёке жизнеугрожающей локализации.

Плановая госпитализация показана при неэффективности терапии и тяжёлом течении — для коррекции тактики и подбора индивидуальной дозы.

Критерии выписки

1. купирование ангиоотёка;
2. подбор адекватной эффективной терапии.

Пациент с установленным диагнозом находится на диспансерном наблюдении, предпочтительно у аллерголога-иммунолога, с контролем терапии **1 раз в 3 месяца**.

Ангиоотёк гортани без своевременной и адекватной терапии фатален; при адекватной пожизненной терапии прогноз благоприятный.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наследственный ангиоотёк»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	267_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Национальная ассоциация экспертов в области первичных иммунодефицитов; Союз педиатров России; Ассоциация медицинских генетиков
Пациенты	Дети и взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.

Клинические рекомендации

Нейросенсорная тугоухость у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H90.3** — Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя **H90.4** — Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.5** — Нейросенсорная потеря слуха неуточненная **H91.1** — Пресбиакузис **H91.2** — Внезапная идиопатическая потеря слуха **H91.8** — Другие уточненные потери слуха
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 22.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/518_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз сенсоневральной тугоухости:
  1. жалобы на снижение слуха;
  2. нормальная отоскопическая картина;
  3. тимпанограмма типа «А»;
  4. средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц **26 дБ и выше**;
  5. костно-воздушный интервал **не более 10 дБ**.
- Степень тугоухости по среднему порогу воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц:
  1. I степень: **26–40 дБ**;
  2. II степень: **41–55 дБ**;
  3. III степень: **56–70 дБ**;
  4. IV степень: **71–90 дБ**;
  5. глухота: **91 дБ и более**.
- Внезапная и острая идиопатическая потеря слуха: тональная аудиометрия **не позднее суток** от первого обращения и повторно перед выпиской.
- Острая сенсоневральная тугоухость:
  1. экстренная госпитализация в оториноларингологическое (или неврологическое) отделение;
  2. глюкокортикоиды по убывающей схеме.
- Хроническая тугоухость, реабилитация:
  1. слуховой аппарат: средний порог в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе **31 дБ и выше**;
  2. кохлеарная имплантация: двусторонняя тугоухость IV степени или глухота.
- Хроническая тугоухость: наблюдение сурдолога-оториноларинголога, тональная и речевая аудиометрия **1–2 раза в год**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Сенсоневральная (нейросенсорная) тугоухость (СНТ) характеризуется снижением слуха вплоть до его утраты вследствие поражения какого-либо участка звуковоспринимающего отдела слухового анализатора, от сенсорного аппарата улитки до невральных структур.

2.2 Этиология и патогенез

Основным условием развития тугоухости является повреждение чувствительных структур улитки. Начальным звеном служит дистрофия волосковых клеток, которая при своевременно оказанной помощи может быть обратимой.

Причинами внезапной и острой СНТ являются инфекционные заболевания (грипп, эпидемический паротит, корь, клещевой энцефалит, менингококковый менингит, скарлатина, дифтерия, тифы, сифилис), острые интоксикации и ототоксические препараты (аминогликозиды, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты, нестероидные противовоспалительные препараты и другие), заболевания сердца и сосудов, в том числе нарушения мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бассейне и нарушения реологических свойств крови, дегенеративные заболевания позвоночника с синдромом позвоночной артерии, а также моногенная наследственная патология и генетическая предрасположенность.

2.3 Степени тугоухости

Степень тугоухости определяется по усреднённому порогу слышимости воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.

Степень	Средний порог воздушного звукопроведения
I степень	26–40 дБ
II степень	41–55 дБ
III степень	56–70 дБ
IV степень	71–90 дБ
Глухота	91 дБ и более

2.4 Другие классификации

По темпу развития

1. внезапная: снижение слуха **до 12 часов**;
2. острая: развивается **за 1–3 суток**, сохраняется до месяца;
3. подострая: сохраняется **1–3 месяца**;
4. хроническая (стойкая): сохраняется **более 3 месяцев**.

По времени возникновения

1. врождённая;
2. приобретённая.

По течению

1. стабильная;
2. прогрессирующая;
3. флюктуирующая;
4. обратимая.

По стороне поражения

1. односторонняя;
2. двусторонняя, симметричная или асимметричная.

По этиологии

1. генетическая (наследственная);
2. мультифакториальная (с наследственной предрасположенностью);
3. приобретённая.

2.5 Клиническая картина

Основные проявления

1. снижение слуха;
2. ухудшение разборчивости речи;
3. шум в ушах;
4. ощущение заложенности ушей.

Ведущей жалобой является снижение слуха в сочетании с шумом в ухе, чаще постоянным, преимущественно смешанной тональности.

Острая сенсоневральная тугоухость проявляется внезапным одно- или двусторонним снижением слуха вплоть до глухоты. В некоторых случаях (острая травма, нарушение кровотока в лабиринтной артерии, токсическое воздействие на структуры лабиринта) оно сопровождается:

1. шумом в ухе;
2. атаксией, головокружением;
3. тошнотой, потливостью;
4. тахикардией, колебаниями артериального давления;
5. спонтанным нистагмом.

2.6 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. время возникновения и темп нарастания снижения слуха;
2. различие слуха на правое и левое ухо;
3. выраженность затруднений при общении;
4. шум в ушах: интенсивность и тональность;
5. вестибулярные нарушения и неврологическую симптоматику.

В анамнезе

1. слух у ближайших родственников;
2. профессиональная деятельность;
3. перенесённые инфекционные и соматические заболевания;
4. наблюдение у других специалистов.

Факторы риска

1. тугоухость у родственников, особенно при совпадении степени, формы и условий возникновения;
2. производственный шум;
3. ототоксические препараты;
4. перенесённые инфекции: менингит, эпидемический паротит, корь, грипп и другие;
5. соматическая патология.

При острой тугоухости анамнез собирают по следующему плану:

1. общее самочувствие и температура тела;
2. на какое ухо снижен слух, когда и при каких обстоятельствах это произошло, изменялся ли слух в динамике, с чем пациент связывает снижение слуха, отмечалось ли оно ранее;
3. наличие шума в ушах;
4. наличие и характер головокружения (с определённым направлением или хаотичное), наличие тошноты, рвоты, диареи, потливости, уменьшение головокружения и шума после рвоты;
5. приступы системного головокружения в анамнезе и установленный ранее диагноз болезни Меньера;
6. отиты в анамнезе, принимаемые лекарственные препараты, уровень артериального давления.

Уточняется также наличие гипертонической, ишемической или цереброваскулярной болезни; травмы головы или шейного отдела позвоночника, интенсивного звукового воздействия, плавания или приёма ванны перед снижением слуха; слабости в конечностях, асимметрии лица, нарушений чувствительности, движений и зрения; недавнего стоматологического лечения или протезирования зубов.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

1. жалобы на снижение слуха, шум в ушах, ухудшение разборчивости речи;
2. нормальная отоскопическая картина;
3. тимпанометрия: тимпанограмма типа «А»; акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха регистрируются или отсутствуют;
4. тональная аудиометрия: средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц **26 дБ и более**, костно-воздушный интервал **не более 10 дБ**;
5. речевая аудиометрия соответствует тональной.

3.2 Отоскопия

Диагностические признаки при сенсоневральной тугоухости (норма)

1. наружный слуховой проход свободный;
2. барабанная перепонка перламутрово-серая, матовая;
3. опознавательные знаки чёткие.

Острая сенсоневральная тугоухость может развиться и у пациента с перенесённой или текущей патологией среднего уха, поэтому отоскопия необходима, однако для постановки диагноза и выбора тактики её недостаточно.

Осматривают также другие ЛОР-органы для исключения заболеваний уха, носа и глотки, нарушающих воздушное звукопроведение.

3.3 Анализы крови

Общий (клинический) анализ крови выполняют всем пациентам.

При сопутствующей патологии

1. липидный спектр: холестерин, липопротеины низкой и высокой плотности (ЛПНП, ЛПВП);
2. биохимический анализ: глюкоза, общий и прямой билирубин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, мочевина;
3. коагулограмма: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО), протромбиновое время, фибриноген;
4. тиреотропный гормон.

3.4 Акуметрия

Всем пациентам с подозрением на сенсоневральную тугоухость (СНТ) составляют слуховой паспорт: исследуют слух шёпотной и разговорной речью, проводят камертональные пробы.

Акуметрия носит ориентировочный характер, однако на приёме оториноларинголога её достаточно для направления пациента к сурдологу-оториноларингологу.

3.5 Тональная пороговая аудиометрия

Базовый метод первичной диагностики и наблюдения при подозрении на СНТ.

Частоты

1. воздушное звукопроведение: 125–8000 Гц;
2. костное звукопроведение: 250–6000 Гц;
3. при нормальных порогах и жалобах на снижение слуха или шум: расширенный диапазон 125–20 000 Гц.

Внезапная и острая идиопатическая потеря слуха: аудиометрия **не позднее суток** от первого обращения; перед выпиской повторно:

1. восстановление порогов до нормы;
2. частичное восстановление;
3. стабилизация (без дальнейшего прогрессирования).

По результату определяют дальнейшую тактику.

Хроническая двусторонняя тугоухость: по аудиограмме определяют показания

1. к слухопротезированию, традиционному или имплантационному, включая кохлеарную имплантацию;
2. при необходимости к направлению на медико-социальную экспертизу (МСЭ) и составлению индивидуальной программы реабилитации.

У пользователей слуховых аппаратов, аппаратов костной проводимости и кохлеарных имплантов оценивают эффективность слухопротезирования и при необходимости корректируют его.

При асимметричном снижении слуха маскируют лучше слышащее (неисследуемое) ухо.

3.6 Надпороговые тесты

Тесты для выявления нарушения функции громкости (рекрутмента)

1. пороги дискомфорта;
2. тест SISI;
3. тест Люшера.

Исследование может быть дополнено сопоставлением порогов слышимости с порогами акустического рефлекса на частотах 500–4000 Гц.

3.7 Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия

При подозрении на СНТ выполняют тимпанометрию и регистрируют акустический рефлекс ипси- и контралатерально.

Цели

1. исключение патологии среднего уха;
2. дифференциальная диагностика сенсоневральной и кондуктивной тугоухости;
3. выявление поражения слухового и лицевого нервов, центральных слуховых путей и ядер VII и VIII пар на уровне продолговатого мозга и моста.

Регистрация рефлекса в широком временном окне (до 10 секунд) позволяет выявить его распад, который является признаком ретрокохлеарного поражения.

Диагностические признаки: тимпанограмма типа «А»; акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха регистрируются или отсутствуют. Других типов тимпанограмм рекомендация не описывает.

3.8 Речевая аудиометрия

Речевую аудиометрию проводят в тишине и на фоне маскирующего шума.

Исследование позволяет определить пороги восприятия и разборчивость речи; речетональная диссоциация (несоответствие речевой и тональной аудиограмм) может указывать на центральные нарушения.

3.9 Электрокохлеография

Метод раннего выявления эндолимфатического гидропса.

В амбулаторных условиях применяют экстратимпанальную электрокохлеографию с внутриушным электродом с регистрацией ответов на стимулы со сгущением и разрежением в начальной фазе.

3.10 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы и отоакустическая эмиссия

Методы дифференциальной и топической диагностики

1. коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП);
2. вызванная отоакустическая эмиссия;
3. отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения.

При асимметричной тугоухости целесообразны предъявление стимулов низкой частоты и сравнение межпиковых интервалов I–V с обеих сторон.

Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) представляет собой слабые звуковые колебания, генерируемые наружными волосковыми клетками улитки и регистрируемые зондом в наружном слуховом проходе. ОАЭ не регистрируется при порогах слышимости выше 25–30 дБ на частотах 1–4 кГц, охватывающих большую часть речевого диапазона.

КСВП отражают электрическую активность слухового пути в ответ на звуковой стимул и регистрируются с поверхности головы. Ответ представляет собой комплекс положительных пиков I–VII, наиболее стабильным из которых является V пик.

3.11 Интерпретация аудиограммы

1. периферическое (кохлеарное) поражение: нисходящая аудиограмма без костно-воздушного разрыва, феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНТ);
2. центральное (корковое и подкорковое) поражение: аудиограмма чаще нисходящая, без костно-воздушного разрыва, ФУНТ отсутствует; значительно нарушены разборчивость речи в шуме и локализация звука.

3.12 Вестибулометрия

Исследуют функцию преддверия и полукружных каналов, чтобы выявить дисфункцию лабиринта и провести дифференциальную диагностику.

3.13 Лучевые методы исследования

Показаны при подозрении на СНТ, особенно при односторонней и асимметричной тугоухости.

Методы

1. магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, в том числе с внутривенным контрастированием: внутренние слуховые проходы, мостомозжечковые углы, задняя черепная ямка;
2. компьютерная томография (КТ) височных костей высокого разрешения, в том числе с болюсным контрастированием.

Для оценки анатомических структур также выполняют

1. рентгенографию шейного отдела позвоночника с функциональными пробами;
2. МРТ головного мозга, при односторонней тугоухости с контрастным усилением, для подтверждения или исключения невриномы слухового нерва.

МРТ позволяет уточнить дифференциальный и топический диагноз, уровень поражения слухового анализатора и анатомические особенности уха.

При сопутствующей патологии

1. дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстра- и интракраниальных отделов) с цветным допплеровским картированием;
2. триплексное сканирование вен.

3.14 Консультации и дифференциальная диагностика

Показания

1. любой вид СНТ независимо от длительности: консультации терапевта, невролога, эндокринолога;
2. аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния: исследование иммунного статуса.

Выявление нарушений липидного и углеводного обмена позволяет обосновать патогенетическое лечение.

Дифференцируют с

1. лабиринтопатиями после хронического гнойного отита, радикальной операции на ухе, перенесённого лабиринтита;
2. поражением внутреннего уха при инфекциях и интоксикациях;
3. невриномой VIII нерва;
4. нарушением кровообращения в вертебро-базилярном бассейне;
5. рассеянным склерозом;
6. объёмными образованиями головного мозга;
7. черепно-мозговой и спинальной травмой;
8. серной пробкой;
9. сахарным диабетом, гипотиреозом, хронической почечной недостаточностью и другими состояниями.

На догоспитальном этапе диагноз острой сенсоневральной тугоухости является предположительным. Однако и предположительный диагноз требует экстренной защиты сенсорных структур внутреннего уха и срочной медицинской эвакуации в многопрофильный стационар с ЛОР-отделением для дифференциальной диагностики и лечения.

Показания

1. подозрение на невриному слухового нерва или другое объёмное образование по МРТ или КТ: консультация нейрохирурга.

---

4. Лечение и реабилитация

4.1 Острая и внезапная тугоухость

1. Экстренная госпитализация в оториноларингологическое или неврологическое отделение.
2. Охранительный слуховой режим.
3. Глюкокортикоиды внутривенно (инфузионно) по убывающей схеме с учётом сопутствующей патологии, противопоказаний и побочных эффектов.

   Глюкокортикоиды могут вводиться системно (внутрь или инфузионно) и местно (транстимпанально и транстубарно), возможно сочетание этих путей введения. В остром периоде сочетанное применение позволяет снизить системную дозу без потери эффективности.

4. При предположительно ишемическом генезе на фоне сердечно-сосудистых нарушений проводится внутривенная инфузионная терапия препаратами для лечения заболеваний нервной системы, например #этилметилгидроксипиридина сукцинатом.

Пациент с диагнозом «острая сенсоневральная тугоухость» направляется на лечение в стационар или дневной стационар.

> В одном разделе рекомендации допускается лечение острой тугоухости в дневном стационаре, тогда как следующая рекомендация предусматривает экстренную госпитализацию в оториноларингологическое или неврологическое отделение.

Препарат	Доза
#Дексаметазон	Внутривенно на 100 мл натрия хлорида: в 1-й и 2-й дни — 24 мг, в 3-й и 4-й — 16 мг, в 5-й — 8 мг, в 6-й — 4 мг, в 7-й день препарат не вводится, в 8-й — 4 мг.
#Этилметилгидроксипиридина сукцинат	Раствор 5% — 4 мл на 16 мл натрия хлорида внутривенно, 8–10 дней.

4.2 Хроническая тугоухость

Поддерживающие курсы лечения назначают по индивидуальным показаниям с учётом соматической патологии.

Охранительный слуховой режим.

Проводят лечение фоновой соматической патологии, а также **1–2 раза в год** курсы поддерживающей терапии таблетированными препаратами, улучшающими мозговой и лабиринтный кровоток и тканевой обмен.

При некоторых формах хронической тугоухости (наследственной, постменингитной, ототоксической) лечение в отдалённом периоде неэффективно.

При острой тугоухости восстановление слуха на фоне лечения ещё возможно, тогда как при хронической вероятность медикаментозного улучшения порогов слышимости крайне мала.

Поэтому при хронической тугоухости корректнее говорить о лечении сопутствующей соматической патологии. Медикаментозное лечение этих нарушений одновременно служит профилактикой прогрессирования тугоухости:

1. сердечно-сосудистых заболеваний;
2. заболеваний нервной системы;
3. эндокринной патологии;
4. нарушений иммунного статуса.

При вестибулярных нарушениях и ушном шуме на фоне хронической тугоухости применяют патогенетическое и симптоматическое лечение.

4.3 Слухопротезирование

Подбор и настройка слуховых аппаратов при среднем пороге на речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) на лучше слышащем ухе **31 дБ и более**.

В алгоритме рекомендации уточнено, что пороги должны быть стабильными, а при выборе аппарата учитываются возраст, профессия, образовательные потребности и социальная активность пациента.

Если использовать слуховые аппараты невозможно, устанавливают имплант среднего уха при порогах костного звукопроведения **не выше 55 дБ на 500 Гц** и **не выше 75 дБ на высоких частотах**.

У пациентов со сниженным зрением и другими инвалидизирующими заболеваниями показания к слухопротезированию расширяются, а требования к техническим средствам реабилитации возрастают.

4.4 Кохлеарная имплантация

При двусторонней тугоухости IV степени или глухоте проводится слухоречевая реабилитация методом кохлеарной имплантации (КИ).

Кохлеарная имплантация остаётся единственным эффективным методом реабилитации при тугоухости высокой степени и глухоте и включает комплекс аудиологических, сурдопедагогических, психологических и хирургических мероприятий.

4.5 Показания к кохлеарной имплантации

№	Показание
1	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени с порогами слуха 80 дБ и более по данным КСВП
2	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени со средними порогами на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц 80 дБ и более по данным тональной пороговой аудиометрии
3	Пороги в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами (бинаурально) выше 55 дБ на частотах 2–4 кГц
4	Отсутствие выраженного улучшения восприятия речи с оптимально подобранными слуховыми аппаратами при среднем пороге выше 95 дБ после 3–6 месяцев их использования (по заключению сурдопедагогической комиссии)
5	Разборчивость речи в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами менее 40% после 3–6 месяцев их использования (по заключению сурдопедагогической комиссии)

> Пороговые значения для кохлеарной имплантации в КР не согласованы с классификацией той же рекомендации. По разделу 1.5 IV степени соответствуют пороги 71–90 дБ, тогда как показания 1 и 2 касаются «IV степени с порогами 80 дБ и более», то есть охватывают и глухоту, но не всю IV степень. Показание 4 предусматривает средний порог выше 95 дБ, что соответствует глухоте, хотя речь в нём идёт о «высокой степени тугоухости».

Абсолютные противопоказания

1. полная аплазия внутреннего уха (аномалия Мишеля);
2. полная облитерация улитки;
3. тяжёлые соматические, неврологические и психические заболевания;
4. недостаточность интеллекта и отсутствие коммуникативных возможностей (исключения возможны для слабовидящих и слепых).

Относительные противопоказания

1. отсутствие мотивации и возможностей для длительной реабилитации;
2. частичная облитерация улитки;
3. выраженные аномалии улитки и слухового нерва;
4. обострение воспалительных заболеваний ЛОР-органов;
5. ретрокохлеарная патология.

При облитерации, аномалиях и ретрокохлеарной патологии решение принимает врачебная комиссия центра, выполняющего операцию.

Двусторонняя (бинауральная) имплантация выполняется одномоментно или последовательно. Она обеспечивает стимуляцию слуховых путей с обеих сторон, локализацию звука, лучшую разборчивость речи в шуме и при разговоре нескольких собеседников, более естественное и менее утомительное восприятие, а также сохранение слуха при поломке одного импланта.

Одномоментная бинауральная имплантация показана при хронической двусторонней тугоухости IV степени и глухоте после перенесённого менингита (при наличии выписки из стационара) по решению врачебной комиссии.

Последовательная бинауральная имплантация показана при оссификации или облитерации улитки после перелома височных костей и при отосклерозе, при аномалиях развития внутреннего уха, а также при хорошей динамике слуха и речи после односторонней имплантации и высокой мотивации; во всех случаях решение принимает врачебная комиссия центра. Объём последовательных имплантаций не должен превышать 10% годового объёма данного вида помощи в учреждении.

Противопоказания аналогичны противопоказаниям к кохлеарной имплантации; дополнительным противопоказанием является интервал между операциями, при котором система КИ используется с одной стороны более 5 лет.

Объём кохлеарной имплантации взрослым пациентам в учреждении не должен превышать 20% государственного задания по данному виду высокотехнологичной медицинской помощи. Гарантийный срок на имплант составляет не менее 10 лет, на речевой процессор не менее 5 лет.

4.6 Повторная имплантация

Причина	Тактика ведения
Техническая неисправность импланта	Реимплантация
Гнойное воспаление среднего уха на стороне импланта (хронический гнойный средний отит, мастоидит)	Санация полостей среднего уха, тимпанопластика. При невозможности сохранения импланта показаны эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Экструзия корпуса импланта	Эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Миграция корпуса импланта, исключающая использование речевого процессора, или экстракохлеарное положение электродной решётки	В таблице КР не заполнено

Реимплантация выполняется системой того же производителя; установка системы другого производителя возможна только за счёт внебюджетных средств, что отражается в информированном согласии.

При выходе импланта из строя в течение гарантийного срока производитель по заявлению медицинской организации в течение 10 суток предоставляет первичное заключение и в течение 30 суток после него предоставляет новый имплант. Неисправность окончательно устанавливается по результатам технической экспертизы извлечённого импланта, продолжительность которой не превышает трёх месяцев.

4.7 Физиотерапевтическое лечение и другие методы реабилитации

Электростимуляция: при тугоухости и шуме в ушах.

Применяются постоянный импульсный ток прямоугольной формы и флюктуирующие токи силой 0,5–2 мА; частота подбирается в соответствии с частотой шума. Продолжительность процедуры 10–15 минут, курс 10–15 процедур. Метод противопоказан пользователям кохлеарного, стволомозгового импланта и импланта среднего уха.

Гипербарическая оксигенация: **10–20 процедур** при давлении 1,5–2,5 атм по 1–2 часа.

Лечение предпочтительно начинать **в течение первого месяца** от начала заболевания; результаты лучше при сочетании с глюкокортикоидами.

Рефлексотерапия.

Метод эффективен как дополнительное лечение, в том числе на поздней стадии; электропунктура эффективнее классической иглорефлексотерапии.

Параметры

1. импульсы длительностью 1 мс переменной полярности частотой 61 Гц;
2. амплитуда до ощущения лёгкого покалывания;
3. по 10 минут на пару точек;
4. курс 10–15 процедур ежедневно или через день.

Электронейростимуляция головного мозга.

Метод наиболее эффективен при начальной и лёгкой степени тугоухости, в том числе при аудиоселективной транскраниальной электростимуляции: сила тока до 1,0 мА, продолжительность 20 минут, 15 процедур через день. Метод противопоказан пользователям имплантов.

Дозированные физические нагрузки.

Используются баланстерапия и дыхательная гимнастика курсами по 3 месяца, 3 раза в неделю по 40 минут, а также ежедневный терренкур продолжительностью не менее 20 минут.

Транскраниальная магнитная стимуляция, в том числе при шуме в ушах на фоне тугоухости.

Выполняют ритмическую стимуляцию височно-теменных, лобных и префронтальных областей коры. Метод противопоказан пользователям имплантов.

Лекарственный ультрафонофорез и внутриушной электрофорез лекарственных препаратов.

В наружный слуховой проход вводится 1,5–2,0 мл лекарственного препарата, нагретого до 36–37 °C. Продолжительность процедуры 5–15 минут при частоте 880 кГц, мощности до 0,2 Вт/см² и гальваническом токе до 0,3 мА; курс 10–12 процедур. Метод противопоказан пользователям имплантов.

Медицинский массаж.

Назначают лечебный массаж шеи и воротниковой зоны (классический, точечный или вакуумный) ежедневно, курсом до 10 процедур.

Лазеротерапия в составе комплексного лечения.

Внутривенное лазерное облучение крови сочетается с введением трентала: длина волны 630 нм, мощность 1,0–2,0 мВт, продолжительность 25–30 минут, 5–7 процедур ежедневно. При эндауральной методике длина волны составляет 808–810 нм, плотность потока 8–15 мВт/см², продолжительность 8–10 минут, 12–14 процедур ежедневно.

Слуховой тренинг в виртуальной реальности.

Метод показан в качестве дополнительного при хронической тугоухости лёгкой степени и скрытой потере слуха: ежедневно в течение 7 дней по 15 минут с одной паузой продолжительностью 2 минуты.

Вестибулярные тренировки, в том числе в виртуальной реальности.

Тренировки равновесия назначают ежедневно или через день по 30 минут, курс 20 процедур.

Мобильные приложения с шумоподавлением в режиме реального времени: для улучшения слуха, в том числе после кохлеарной имплантации.

Методы, перечисленные в пунктах 4–15 раздела реабилитации, как правило, применяются в ходе санаторно-курортного лечения после консультации врача.

4.8 Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение рекомендуется в хронической стадии тугоухости, врождённой или приобретённой; в таблице КР перечислены все степени, от I до глухоты.

Код	Заболевание
H90.3	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя
H90.4	Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе
H90.5	Нейросенсорная потеря слуха неуточнённая

Показаны бальнеологические курорты с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми и йодобромными водами, климатические (приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные) и грязевые курорты.

При неэффективности как слуховых аппаратов, так и кохлеарных имплантов необходим альтернативный способ коммуникации: обучение дактилю и жестовому языку, сурдоперевод.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Диспансерное наблюдение у сурдолога-оториноларинголога в сурдологическом кабинете или центре по месту жительства.

Эффективность слуховых аппаратов оценивают по речевой аудиометрии в свободном звуковом поле в тишине и в шуме и по анкете о качестве жизни. Тональную и речевую аудиометрию в тишине и в шуме с коррекцией настроек аппарата повторяют **1–2 раза в год**.

При остром ухудшении или быстром прогрессировании тугоухости исследование повторяется незамедлительно для своевременного проведения лечения и восстановления порогов.

После кохлеарной имплантации

1. речевая аудиометрия в свободном звуковом поле в тишине и в шуме: после подключения процессора и на каждой настроечной сессии, **2–4 раза в год**, с анкетированием;
2. тональная и речевая аудиометрия: **1–2 раза в год**;
3. настройка речевого процессора: **2–4 раза в год**.

Для оценки эффективности слуховых аппаратов в рекомендации приведён опросник «Международная оценка использования слуховых аппаратов» из 7 вопросов. Если во всех вопросах выбраны ответы 1 и 2, необходимы коррекция настроек, повторное обследование слуха и направление пациента на слухоречевую реабилитацию; если во всех вопросах выбран вариант 3, требуется коррекция настроек; при вариантах 4 и 5 изменение настроек не требуется.

При односторонней тугоухости необходима дополнительная дифференциальная диагностика, при вестибулярных нарушениях и ушном шуме требуются дополнительные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия.

По показаниям пациента направляют на медико-социальную экспертизу для решения вопроса о стойкой нетрудоспособности.

Одновременно с установлением группы инвалидности составляют индивидуальную программу реабилитации с выбранным способом коррекции слуха

1. традиционное слухопротезирование;
2. имплантационное слухопротезирование;
3. кохлеарная имплантация.

5.1 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. острая сенсоневральная тугоухость;
2. замена речевого процессора системы кохлеарной имплантации (круглосуточный или дневной стационар).

Пациента выписывают при выздоровлении или улучшении состояния.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Нейросенсорная тугоухость у взрослых»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 22.03.2023 (год утверждения в PDF не заполнен: «20__»)
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года; следующая версия ожидалась не позднее марта 2026 года, но на 22.10.2026 в рубрикаторе действует эта
Код в рубрикаторе	518_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Пороги для кохлеарной имплантации не согласованы с классификацией: IV степени соответствуют пороги 71–90 дБ, тогда как в показаниях указаны «IV степень с порогами 80 дБ и более» и средний порог «более 95 дБ» (по классификации это соответствует глухоте).
- В разделе 3.1 пациент с острой тугоухостью направляется «в стационар или дневной стационар», тогда как следующая рекомендация предусматривает экстренную госпитализацию.
- В схеме #дексаметазона на 7-й день препарат не вводится, а на 8-й день вновь вводится 4 мг; так указано в тексте КР.

Клинические рекомендации

Нейросенсорная тугоухость у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H90.3** — Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя **H90.4** — Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.5** — Нейросенсорная потеря слуха неуточненная
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 10.02.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/22_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Основные признаки: отсутствие или сомнительная реакция ребёнка на звуки, задержка речевого развития, а при снижении слуха после овладения речью — распад речи. Степени тугоухости по среднему порогу воздушной проводимости на 500, 1000, 2000 и 4000 Гц:
  1. I степень: **26–40 дБ**;
  2. II степень: **41–55 дБ**;
  3. III степень: **56–70 дБ**;
  4. IV степень: **71–90 дБ**;
  5. глухота: **91 дБ и более**.
- Аудиологический скрининг всем новорождённым:
  1. 1-й этап, регистрация ОАЭ: **до 1 месяца**;
  2. 2-й этап, подтверждающая диагностика в сурдологическом центре: **до 3 месяцев**;
  3. начало реабилитации при подтверждённой тугоухости: **до 6 месяцев**.

  Дети с факторами риска проходят полное аудиологическое обследование независимо от результата скрининга.
- При острой тугоухости назначают глюкокортикоиды системно или интратимпанально и госпитализируют пациента. Консервативное лечение хронической (стойкой) тугоухости не проводится.
- Слухопротезирование показано при двусторонней хронической тугоухости со средним порогом на лучше слышащем ухе **31 дБ и более**.
- Кохлеарная имплантация показана при хронической двусторонней тугоухости IV степени или глухоте (пороги **80 дБ и более** на 500–4000 Гц) без эффекта от слуховых аппаратов за **3–6 месяцев**; приоритет у детей **до 3 лет**.
- Без этапа слуховых аппаратов на КИ направляют детей с двусторонней тугоухостью IV степени или глухотой:
  1. при подтверждённой наследственной тугоухости (мутации гена GJB2 и других генов);
  2. после перенесённого менингита (менингоэнцефалита).

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Сенсоневральная тугоухость (СНТ): снижение слуха вплоть до утраты при поражении звуковоспринимающего отдела слухового анализатора, от сенсорного аппарата улитки до невральных структур.

2.2 Классификация

По степени тяжести: средний порог воздушной проводимости на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц

1. I степень: **26–40 дБ**;
2. II степень: **41–55 дБ**;
3. III степень: **56–70 дБ**;
4. IV степень: **71–90 дБ**;
5. глухота: **91 дБ и более**.

По времени возникновения

1. врождённая: тугоухость с рождения или выявленный патологический генотип независимо от срока выявления тугоухости;
2. приобретённая: после установленной причины с ухудшением реакции на звуки и возможным регрессом речи, или по неизвестной причине при доказанном ранее нормальном слухе.

По остроте

1. внезапная (идиопатическая): развивается **до 12 часов**;
2. острая: развивается **за 1–3 суток**, сохраняется **до 1 месяца**;
3. подострая: **1–3 месяца** от начала;
4. хроническая (стойкая): **более 3 месяцев** или нет данных о начале.

По течению

1. стабильная;
2. прогрессирующая;
3. флюктуирующая;
4. с улучшением.

По речевому развитию

1. доречевая (долингвальная): до овладения речью;
2. послеречевая (постлингвальная): после овладения речью.

2.3 Этиология

Наследственные причины

1. изменения генотипа у 70% детей с врождённой и доречевой тугоухостью, в 70–85% несиндромальные формы;
2. чаще всего выявляют мутации гена GJB2 (коннексин 26), в России прежде всего 35delG — более чем у 50% детей со стойкой двусторонней тугоухостью; рецессивные мутации приводят к врождённой двусторонней тугоухости тяжёлой степени и глухоте;
3. синдромальные формы: синдромы Пендреда, Ашера IIA, бранхио-ото-ренальный, Ваарденбурга и другие.

Ненаследственные причины врождённой тугоухости

1. самой частой причиной считается врождённая цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ); при бессимптомной форме тугоухость развивается в 25% случаев, в половине из них прогрессирует;
2. реже причиной бывают краснуха, токсоплазмоз, сифилис.

Причины приобретённой тугоухости

1. менингит;
2. вирусные детские инфекции;
3. ототоксические препараты: аминогликозиды, диуретики и другие;
4. травмы головы: перелом височных костей, основания черепа;
5. нейродегенеративные заболевания.

Факторы риска стойкой врождённой и перинатальной тугоухости

1. ближайшие родственники с нарушением слуха с детства;
2. синдромы или генетические заболевания, связанные с нарушением слуха;
3. аномалии ушной раковины, слухового прохода, другие челюстно-лицевые аномалии (кроме ушных привесков и изолированной расщелины верхней губы);
4. внутриутробные инфекции: ЦМВИ, краснуха, токсоплазмоз, сифилис;
5. пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых **более 48 часов**;
6. недоношенность **32 недели и менее** или масса тела при рождении **менее 1500 г**;
7. гипербилирубинемия, потребовавшая заменного переливания крови;
8. перинатальная асфиксия, гипоксия;
9. тяжёлое гипоксически-ишемическое или геморрагическое поражение ЦНС, ДЦП, органическое поражение ЦНС, нейродегенеративные заболевания;
10. лечение ототоксическими препаратами;
11. экстракорпоральная мембранная оксигенация.

2.4 Клиническая картина

Признаки

1. нет или сомнительная реакция на окружающие звуки;
2. задержка этапов речевого развития: гуления, лепета, первых слов, простых фраз;
3. после овладения речью: распад речи — нет новых слов, ухудшается звукопроизношение вплоть до исчезновения устной речи;
4. старшие дети сами отмечают снижение слуха, плохую разборчивость речи, шум в ушах.

В анамнезе уточняют

1. слух ближайших родственников;
2. течение беременности, гестационный возраст, течение родов, массу тела при рождении, оценку по шкале Апгар;
3. течение перинатального периода;
4. инфекционные и соматические заболевания, наблюдение у других специалистов.

Отоскопия: слуховой проход свободный, барабанная перепонка перламутрово-серая, матовая, опознавательные знаки чёткие. Осматривают и другие ЛОР-органы, чтобы исключить нарушение воздушного звукопроведения.

---

3. Диагностика

Перед исследованием слуха выполняют отоскопию. У детей раннего возраста диагноз основан на объективных методах (ОАЭ, КСВП, ASSR, акустическая импедансометрия) и оценке поведенческих реакций на звуки и речь; у старших дошкольников и школьников добавляют тональную пороговую, надпороговую и речевую аудиометрию.

Критерии диагноза

1. подозрение на тугоухость: по данным скрининга новорождённых, при отсутствии или изменении реакций на звуки, задержке или нарушении речевого развития, жалобах на снижение слуха, наличии факторов риска;
2. нормальная отоскопическая картина;
3. повышение порогов и (или) изменение морфологии пиков КСВП (при слуховой нейропатии регистрируется микрофонный потенциал улитки), повышение порогов ASSR, отсутствие ОАЭ (при слуховой нейропатии ОАЭ может регистрироваться), повышение порогов при тональной аудиометрии по типу нарушения звуковосприятия.

3.1 Аудиологический скрининг новорождённых

Всем новорождённым регистрируют отоакустическую эмиссию (ОАЭ) перед выпиской из роддома и (или) в поликлинике **до 1 месяца**.

Детям, не прошедшим скрининг в роддоме, и родившимся вне родовспомогательного учреждения ОАЭ регистрируют в поликлинике **до 3 месяцев**. При более позднем обращении с сомнительной реакцией на звуки незамедлительно направляют на полное обследование в специализированный центр.

Протокол

1. ОАЭ на **3–4-е сутки** в роддоме, при переводе в отделение патологии новорождённых — при выписке;
2. нет чёткого ответа на одно или оба уха: повтор в поликлинике **в 1 месяц**;
3. ОАЭ не зарегистрирована: 2-й этап в сурдологическом центре **до 3 месяцев**.

Полное аудиологическое обследование независимо от результата скрининга

1. ближайшие родственники с нарушением слуха с детства;
2. синдромы, связанные с нарушением слуха;
3. челюстно-лицевые аномалии (кроме ушных привесков и изолированной расщелины верхней губы);
4. внутриутробные инфекции: ЦМВИ, краснуха, токсоплазмоз, сифилис;
5. реанимация новорождённых **более 48 часов**;
6. недоношенность **32 недели и менее** или масса тела **менее 1500 г**;
7. тяжёлая гипербилирубинемия с заменным переливанием крови;
8. тяжёлое гипоксически-ишемическое или геморрагическое поражение ЦНС;
9. ототоксические препараты.

У новорождённых высокого риска возможна отсроченная или прогрессирующая тугоухость. При задержке слуховых реакций или речи на любом этапе ребёнка направляют на исследование слуха по возрасту.

3.2 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы и ASSR

Показания

1. ОАЭ не зарегистрирована на 1-м этапе скрининга;
2. дети **до 3 лет** с факторами риска;
3. дети **до 3 лет** с задержкой развития, когда поведенческие реакции на звуки трудно оценить.

Проводят в сурдологическом центре во время естественного сна; под медикаментозной седацией — только в учреждении с реанимационной службой.

Методика исследования

1. пороги КСВП в каждом ухе на щелчки и (или) широкополосные Chirp-стимулы, шаг не более 10 дБ; анализ морфологии, межпиковых интервалов и латентностей;
2. для выявления слуховой нейропатии: стимулы противоположной полярности, внутриушные телефоны, тест с пережатым звуководом для верификации микрофонного потенциала;
3. для степени тугоухости и слухопротезирования нужна частотно-специфичная информация: ASSR, тональные посылки 1000 или 500 Гц;
4. ASSR не используют изолированно (ей предшествует КСВП на щелчок) и при подтверждённой слуховой нейропатии.

3.3 Отоакустическая эмиссия

При подозрении на нарушение слуха регистрируют задержанную вызванную ОАЭ и (или) ОАЭ на частоте продукта искажения для оценки функции улитки.

Проводят и при нормальных порогах КСВП на щелчки — для частотно-специфичной информации.

3.4 Акустическая импедансометрия

Всем детям, обследуемым у сурдолога-оториноларинголога, выполняют тимпанометрию и акустическую рефлексометрию.

Детям **до 6 месяцев** тимпанометрию проводят с высокочастотным зондирующим тоном (обычно 1000 Гц), недоношенным — **до 8–12 месяцев**.

3.5 Аудиометрия по возрасту

От 6 месяцев до 2 лет: тональная пороговая аудиометрия со зрительным подкреплением.

Ребёнок с родителем в звукозаглушённой камере; на звук (трель 1000 Гц) ребёнок поворачивается — включается игрушка или картинка. Частоты 250–4000 Гц. В свободном звуковом поле результат относят к лучше слышащему уху.

От 2 до 5 лет: игровая аудиометрия, пороги на 125–8000 Гц для каждого уха по воздушной и костной проводимости.

Старше 5 лет: тональная пороговая аудиометрия по стандартной методике на 125–8000 Гц по воздушной и костной проводимости.

При возможности исследуют расширенный диапазон до 16–20 кГц, в том числе для контроля ототоксичности.

Старше 6–7 лет: речевая аудиометрия в тишине и на фоне шума.

Тоно-речевая диссоциация может указывать на слуховую нейропатию или центральные слуховые расстройства.

Открытый выбор: ребёнок повторяет слово; закрытый: показывает картинку. Подача в телефонах или в свободном звуковом поле; при подаче в оба уха или через колонки результат относится к лучше слышащему уху. Для оценки слухопротезирования и КИ — в свободном звуковом поле.

Старше 6–7 лет: надпороговая аудиометрия; определяют пороги дискомфорта и выполняют тесты на центральные слуховые расстройства.

Исследование позволяет определить уровень поражения; центральные расстройства меняют тактику реабилитации.

3.6 Молекулярно-генетическое исследование гена GJB2

Всем детям с несиндромальной двусторонней СНТ любой степени исследуют кровь на мутацию 35delG гена GJB2.

При двух рецессивных мутациях GJB2 и без воспаления в среднем ухе восстановления слуха не ждут, пороги обычно стабильны; раннее начало реабилитации даёт хороший результат.

Консультация врача-генетика по результатам молекулярно-генетического исследования.

3.7 ПЦР на цитомегаловирус

Новорождённым с подозрением на ЦМВИ определяют ДНК цитомегаловируса в мазке со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР в первые **3 недели жизни**.

Субклиническая врождённая ЦМВИ является причиной 20% нарушений слуха у новорождённых; тугоухость может развиться отсроченно.

3.8 КТ височных костей и МРТ

Показания

1. тугоухость неясной этиологии и (или) односторонняя: КТ височных костей с шагом **не более 0,6 мм**.
2. по показаниям: МРТ головного мозга (мостомозжечковый угол) и внутреннего уха.

Диагностические признаки

1. КТ: аномалии внутреннего уха, изменения внутреннего слухового прохода, оссификация лабиринта;
2. МРТ: гипо- и аплазия, объёмные образования слухового нерва, фиброзная облитерация, ликворные свищи лабиринта, поражения центральных отделов.

3.9 Оценка развития и консультации

Всем детям с нарушением слуха проводят оценку слухоречевого, когнитивного и коммуникативного развития. Слухоречевое развитие оценивает сурдопедагог по опросникам, общее развитие — специалист, предпочтительно психолог.

Опросники и шкалы

1. слухоречевое развитие: LittlEARS, шкалы уровней слухового восприятия и разборчивости речи, PEACH, Макартуровский опросник, батарея EARS;
2. общее развитие: шкала KID (до 16 месяцев), RCDI-2000 (от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев), M-CHAT (16–30 месяцев), тест Векслера (старше 4 лет), матрицы Равена (старше 5 лет).

Показана консультация педиатра, при необходимости — других специалистов:

1. невролог;
2. офтальмолог;
3. генетик;
4. кардиолог;
5. нефролог;
6. медицинский психолог;
7. психиатр.

У 24–40% детей с нарушением слуха есть дополнительные расстройства, влияющие на реабилитацию.

---

4. Лечение

4.1 Консервативное лечение

Острая СНТ

При острой СНТ любой этиологии показаны глюкокортикоиды системно или интратимпанально. Схема, приведённая в КР в качестве примера:

1. #метилпреднизолон: 1 мг/кг в сутки внутрь 1 раз в день;
2. длительность: **14 дней**, с постепенным снижением дозы **каждые 4 дня**.

Хроническая (стойкая) СНТ

Консервативное лечение хронической (стойкой) СНТ у детей не проводится.

Сопутствующая патология

При острой, подострой и хронической СНТ лечение сопутствующей неврологической и иной патологии проводят профильные специалисты.

4.2 Индивидуальная программа реабилитации

Индивидуальная программа реабилитации формируется при подтверждённой тугоухости **до 6 месяцев** (у недоношенных — скорректированного возраста) и начинается незамедлительно после выявления нарушения слуха.

Включает

1. слухопротезирование;
2. помощь сурдопедагога, логопеда и психолога;
3. информационную и психологическую поддержку семьи;
4. социальную поддержку;
5. диспансерное наблюдение.

При оформлении инвалидности готовят заключение для МСЭ с реабилитационными мероприятиями и техническими средствами реабилитации (ТСР).

Реабилитационный статус, реабилитационный диагноз и потенциал оценивает мультидисциплинарная реабилитационная команда; она же разрабатывает комплекс мероприятий по индивидуальной программе медицинской реабилитации (ИПМР).

Состав команды

1. врач по медицинской реабилитации;
2. врач-сурдолог-оториноларинголог;
3. сурдопедагог;
4. медицинский логопед (логопед);
5. медицинский психолог (психолог).

4.3 Слухопротезирование

Показания

1. двусторонняя хроническая тугоухость: средний порог воздушной проводимости на 500–4000 Гц на лучше слышащем ухе **31 дБ и более**;
2. двусторонняя тугоухость I степени и корригируемая односторонняя: решение после речевого тестирования и (или) психолого-педагогической оценки;
3. некорригируемая односторонняя тугоухость (глухота): системы выносного микрофона.

Противопоказания

1. острое снижение слуха: нужна диагностика и лечение;
2. для аппаратов воздушного звукопроведения: обострение гнойного воспаления наружного или среднего уха;
3. в ряде случаев тяжёлое головокружение.

Показания к слухопротезированию определяют по данным КСВП и ASSR и по поведенческим порогам методикой, соответствующей возрасту.

Валидацию, то есть оценку эффективности слухопротезирования и программы реабилитации, проводят **не реже 1 раза в 6 месяцев**: используют один-два аудиологических метода, анкету и сурдопедагогическое тестирование.

При неудовлетворительном результате ищут и устраняют причину и повторяют валидацию **через 1–3 месяца**.

1. тональные пороги с аппаратом или имплантом в свободном поле для каждого уха;
2. речевая аудиометрия с аппаратом в свободном поле детям старше 5 лет при достаточном развитии речи, в тишине и в шуме;
3. анкетирование родителей и педагогов, батарея EARS;
4. критерии эффективности: положительная динамика слухового и речевого развития, рост разборчивости слов в тишине.

Адаптация к аппарату, как правило, занимает **1–3 месяца**: за это время необходимо не менее 1–4 повторных консультаций сурдолога и сурдопедагога. В первые 2 года пользования настройки контролируют **не реже раза в 3 месяца**. Частота дальнейшего наблюдения приведена в разделе «Диспансерное наблюдение».

Все дети с аппаратами и имплантами являются кандидатами на вспомогательные слуховые технологии, особенно школьники, дети с высокой степенью тугоухости, слуховой нейропатией и центральными расстройствами. К таким технологиям относятся:

1. персональные и коллективные FM-системы;
2. индукционные устройства;
3. цифровые системы: выносные микрофоны, беспроводные стримеры;
4. телефоны с усилителем, с текстовым выходом;
5. телевизор с телетекстом;
6. вибрационные и световые сигнализаторы звука.

4.4 Кохлеарная имплантация

Показания

1. хроническая двусторонняя СНТ IV степени или глухота со средними порогами **80 дБ и более** на 500–4000 Гц по комплексному обследованию, включая КСВП и ASSR;
2. пороги в свободном поле с оптимально подобранными аппаратами на оба уха **выше 40 дБ** на 0,5–4 кГц;
3. нет выраженного улучшения восприятия речи с аппаратами **за 3–6 месяцев** по заключению сурдопедагогической комиссии;
4. слуховая нейропатия любой степени при неэффективности аппаратов **не менее 3–6 месяцев**.

Сроки и порядок направления на КИ

1. приоритет: дети **до 3 лет**;
2. **старше 3 лет** без слухоречевых навыков: по решению врачебной комиссии центра после консультации сурдолога и педагогического наблюдения;
3. вопрос о КИ решают после постоянного ношения аппаратов на оба уха **3–6 месяцев**;
4. исключение: при двусторонней тугоухости IV степени или глухоте с подтверждённой наследственной тугоухостью (мутации гена GJB2 и других генов) или после менингита (менингоэнцефалита) ребёнка направляют на КИ, **минуя этап слуховых аппаратов**.

Срок пробного ношения аппаратов может быть сокращён при подтверждённой мутации 35delG гена GJB2 в гомозиготном или компаунд-гетерозиготном состоянии.

Абсолютные противопоказания

1. полная аплазия внутреннего уха (аномалия Michel);
2. полная облитерация улитки;
3. тяжёлые соматические, неврологические и психические заболевания, препятствующие наркозу, пользованию имплантом и реабилитации.

Относительные противопоказания (решает врачебная комиссия центра)

1. нет мотивации и возможностей семьи для длительной реабилитации;
2. частичная облитерация улитки;
3. аномалии развития улитки и слухового нерва;
4. обострение воспалительных заболеваний ЛОР-органов;
5. ретрокохлеарная патология.

Показания к двусторонней кохлеарной имплантации

Одномоментная

1. хроническая двусторонняя СНТ IV степени и глухота после менингита (с выпиской из стационара), по решению врачебной комиссии.

Последовательная

1. оссификация или облитерация улитки после перелома височных костей и отосклероза;
2. комбинированные или изолированные аномалии внутреннего уха;
3. нарушения зрения;
4. положительная динамика после односторонней КИ при высокой мотивации семьи; не более 20% годового объёма таких операций в учреждении.

Двусторонняя имплантация позволяет определять направление на источник звука, улучшает разборчивость речи в шуме и динамику развития речи, а при поломке одного импланта слух сохраняется на другой стороне.

Гарантийный срок импланта не менее 10 лет, речевого процессора не менее 5 лет.

Повторная кохлеарная имплантация (реимплантация)

Причина	Методы лечения
Техническая неисправность кохлеарного импланта	Реимплантация кохлеарного импланта
Гнойные воспалительные заболевания среднего уха на стороне импланта (хронический гнойный средний отит, мастоидит)	Санация полостей среднего уха, тимпанопластика; если имплант сохранить нельзя — эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на противоположном ухе при отсутствии противопоказаний
Экструзия корпуса внутренней части импланта	Эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на противоположном ухе при отсутствии противопоказаний
Миграция корпуса внутренней части с невозможностью пользоваться речевым процессором, экстракохлеарное положение электродной решётки	Репозиция внутренней части системы КИ

Реимплантацию выполняют по решению комиссии оперирующей клиники. При поломке импланта в гарантийный срок производитель проводит предварительную экспертизу и предоставляет новую внутреннюю часть; окончательно неисправность устанавливает техническая экспертиза извлечённого импланта.

Стволомозговой слуховой имплант: показания (решает врачебная комиссия)

1. двусторонняя глухота при повреждении слуховых нервов: нейрофиброматоз 2 типа, черепно-мозговая травма;
2. значительная или полная оссификация улиток;
3. аплазия слуховых нервов или улиток.

Противопоказания

1. сопутствующая патология, препятствующая операции;
2. нет мотивации и возможностей семьи для длительной реабилитации.

4.5 Психолого-педагогическая помощь

Всем детям с нарушением слуха на этапе диагностики, до, во время и после слухопротезирования показаны занятия и консультации сурдопедагога, логопеда и психолога с вовлечением семьи, включая консультации близких по уходу за ТСР, общению с ребёнком и занятиям дома.

При долингвальной тугоухости развивают слуховое восприятие и устную речь с аппаратом или имплантом: занятия с сурдопедагогом 1–5 раз в неделю на протяжении 1–7 лет.

При постлингвальной тугоухости проводят адаптацию к восприятию с ТСР и развитие слухо-зрительного восприятия речи: 1–100 занятий с сурдопедагогом.

4.6 Физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, санаторно-курортное лечение

Физиотерапия в курсе лечения: гальванизация, внутриушной электрофорез, электростимуляция, амплипульстерапия, магнитотерапия, ультрафиолетовое и лазерное излучение, вибротерапия, оксигенотерапия; курс 8–10 процедур ежедневно или через день.

Общие противопоказания к назначению физических факторов

1. тяжёлое общее состояние;
2. гипертермия;
3. выраженная интоксикация;
4. гипотрофия 2–3 степени;
5. болезни крови, повышенная кровоточивость;
6. туберкулёз в активной фазе и в период виража туберкулиновых проб;
7. недостаточность кровообращения 2–3 степени;
8. выраженная почечная и печёночная недостаточность;
9. злокачественные новообразования.

Детям с кохлеарным, стволомозговым имплантом и имплантом среднего уха магнитотерапия и электротерапия на голову и шейно-воротниковую область противопоказаны; гидрокинезотерапия — со снятой наружной частью импланта.

Лечебная физкультура: баланс-терапия и дыхательная гимнастика курсами 3 месяца, 3 раза в неделю по 30–40 минут; терренкур не менее 20 минут ежедневно.

Лечебный массаж околоушной, затылочной и воротниковой области ежедневно, курс 8–10 процедур.

Мобильные приложения с шумоподавлением в реальном времени, в том числе после кохлеарной имплантации.

Санаторно-курортное лечение 1 раз в год по показаниям, при хронической стадии.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

1. острая сенсоневральная тугоухость;
2. замена речевого процессора КИ (дневной стационар);
3. объективное аудиологическое обследование под общей анестезией (дневной стационар).

Показания к выписке

1. выздоровление;
2. улучшение.

5.2 Диспансерное наблюдение

При подтверждённой СНТ ребёнок наблюдается у сурдолога-оториноларинголога по месту жительства.

Частота аудиологических обследований

1. первые 2 года жизни и (или) пользования аппаратом: **не реже раза в 3 месяца**;
2. 2–5 лет и (или) 2–3-й год пользования: **каждые 3–6 месяцев**;
3. **старше 5 лет** и (или) после 3–4 лет пользования: **1–2 раза в год**;
4. после КИ — по КР «Реабилитация пациентов после КИ».

Односторонняя тугоухость или не требующая слухопротезирования: слух, язык и речь **каждые 6 месяцев до 3 лет**, далее 1–2 раза в год.

Частота наблюдения после настройки слухового аппарата (раздел 4 КР)

1. дети до 2 лет: **раз в 3 месяца**;
2. до 6–7 лет: **раз в 6 месяцев**;
3. далее 1–2 раза в год.

Детям с аппаратами и имплантами показано диспансерное наблюдение оториноларинголога и сурдолога-оториноларинголога.

Для особых групп (аномалии улитки и слухового нерва, оссификация улитки, слуховая нейропатия, сопутствующие нарушения, длительная глухота, тугоухость после черепно-мозговой травмы) график тестирования и настройки составляют индивидуально.

При любой форме врождённой ЦМВИ ребёнок наблюдается у сурдолога-оториноларинголога: тугоухость может развиться отсроченно.

Частота обследований

1. до 12 месяцев: **раз в 3 месяца**;
2. 13–36 месяцев: **раз в 6 месяцев**;
3. 3–6 лет: **раз в 12 месяцев**.

5.3 Медико-социальная экспертиза

Показания к направлению на МСЭ при двусторонней тугоухости

1. II степени (**41–55 дБ**) со стойкими умеренными нарушениями языковых и речевых функций;
2. III степени (**56–70 дБ**);
3. IV степени (**71–90 дБ**), в том числе после КИ;
4. двусторонней глухоте (**более 91 дБ**), в том числе после КИ;
5. III–IV степени на одно ухо и глухоте на другое;
6. сочетании нарушений зрения и слуха, нарушениях артикуляции и голосообразования.

А также при ограничениях жизнедеятельности (общение, ориентация, обучение и другие) и потребности в социальной защите, включая реабилитацию. Направление оформляет поликлиника по результатам аудиологического обследования.

При двусторонней СНТ III–IV степени и глухоте инвалидность устанавливается без указания срока переосвидетельствования.

Всем признанным инвалидами разрабатывают индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА); выписку из неё МСЭ направляет в органы, которые организуют её выполнение.

Повторное обследование при слухопротезировании

1. поведенческая аудиометрия по воздушной и костной проводимости;
2. акустическая импедансометрия;
3. настройка по аудиометрии и возрасту;
4. проверка аппарата и индивидуального вкладыша, измерения в реальном ухе и функционального усиления при возможности.

После кохлеарной имплантации

1. сурдопедагогическое тестирование;
2. тональная (игровая) аудиометрия в свободном поле;
3. телеметрия нервного ответа;
4. речевая аудиометрия в свободном поле;
5. настройка речевого процессора, консультация сурдопедагога.

Сроки пользования: слуховой аппарат не менее 4 лет, индивидуальный вкладыш не менее 1 года. Досрочная замена проводится при невозможности ремонта или ухудшении порогов, не компенсируемом аппаратом. Речевой процессор КИ заменяют через 5 лет за счёт ОМС.

При острой СНТ есть вероятность восстановить слух лечением, при хронической медикаментозно повысить слух практически невозможно: проводится лечение сопутствующей патологии, при вестибулярных нарушениях и шуме — патогенетически и симптоматически. При сниженном зрении и других инвалидизирующих заболеваниях показания к слухопротезированию расширяются. Если аппараты и импланты не помогают — обучение дактильной азбуке и жестовому языку.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Нейросенсорная тугоухость у детей»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 10.02.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее февраля 2028 года
Код в рубрикаторе	22_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Союз педиатров России
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Частота наблюдения детей со слуховыми аппаратами: в разделе 4 указано 1 раз в 6 месяцев до 6–7 лет, в разделе 5 указано каждые 3–6 месяцев в возрасте 2–5 лет и 1–2 раза в год старше 5 лет. На странице приведены оба варианта.

Клинические рекомендации

Носовое кровотечение

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**R04.0** — Носовое кровотечение
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 08.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/977_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Первое мероприятие при кровотечении из передних отделов полости носа: плотное прижатие крыльев носа к носовой перегородке **на 5 минут и более**.
- Если кровотечение не угрожает жизни, порядок действий:
  1. местная остановка кровотечения: прижатие крыльев носа, сосудосуживающие средства, коагуляция или тампонада;
  2. только после этого коррекция гемостаза или отмена антикоагулянтов.
- При продолжающемся кровотечении, источник которого визуализировать не удаётся, необходима передняя тампонада полости носа.
- Артериальное давление измеряют у каждого пациента, что позволяет выявить артериальную гипертензию и оценить объём кровопотери.
- Показания к госпитализации:
  1. неэффективность первичных мероприятий;
  2. значительная кровопотеря или интенсивное кровотечение;
  3. признаки гиповолемии;
  4. тяжёлая сопутствующая патология;
  5. высокий риск рецидива.

  Госпитализация обязательна, если нужны

  1. переливание крови;
  2. задняя тампонада;
  3. перевязка сосудов;
  4. эмболизация;
  5. передняя тампонада нерассасывающимся материалом, если удалить тампоны амбулаторно невозможно.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Под носовым кровотечением понимается кровотечение из повреждённых сосудов полости носа, околоносовых пазух или носоглотки, а также из сосудов полости черепа при повреждении верхней стенки полости носа.

2.2 Этиология

Различают посттравматические, в том числе послеоперационные, и спонтанные носовые кровотечения. Спонтанное кровотечение является симптомом местного или общего заболевания.

Поражение сосудов слизистой оболочки полости носа наблюдается при её атрофии, специфическом воспалении (туберкулёз, сифилис), опухолях полости носа и околоносовых пазух, сосудистых мальформациях, гранулематозе с полиангиитом.

У детей кровотечение в большинстве случаев обусловлено повреждением слизистой оболочки (инородное тело, травма, в том числе ятрогенная), острыми инфекциями верхних дыхательных путей и опухолями.

У детей до двух лет носовое кровотечение встречается очень редко, приблизительно в одном случае из 10 000. При возникновении кровотечения в этом возрасте необходимо исключить заболевания крови и врождённую патологию, в частности гемангиому полости носа и носоглотки.

2.3 Классификация

По механизму развития

1. изменения сосудов полости носа;
2. нарушения свёртывания крови;
3. сочетание этих причин.

По источнику

1. передние отделы полости носа;
2. задние отделы полости носа;
3. околоносовые пазухи;
4. носоглотка;
5. внутричерепные сосуды.

2.4 Клиническая картина

При переднем кровотечении кровь вытекает преимущественно наружу, при заднем стекает в носоглотку.

Жалобы

1. кровянистые выделения из носа;
2. стекание крови по задней стенке глотки;
3. недомогание;
4. при заглатывании крови дискомфорт в животе, тошнота, стул чёрного цвета.

2.5 Общие симптомы и объём кровопотери

Шок	Признаки	Кровопотеря
Отсутствует	Признаки отсутствуют	до 10% объёма циркулирующей крови (до 500 мл)
Лёгкий	Пульс до 100, систолическое артериальное давление выше 100 мм рт. ст., конечности холодные, диурез не нарушен	15–20% (750–1250 мл)
Средний	Пульс до 120, систолическое артериальное давление 90–100 мм рт. ст., пульсовое давление снижено, беспокойство, потливость, бледность кожных покровов, диурез менее 50 мл в час	25–35% (1250–1750 мл)
Тяжёлый	Пульс более 120, систолическое артериальное давление ниже 60 мм рт. ст. или не определяется, ступор, резкая бледность кожных покровов, конечности холодные, сухость языка и кожи, анурия	более 35% (более 1750 мл)

2.6 Анамнез

При сборе анамнеза уточняют

1. время начала, длительность и частоту кровотечений;
2. сторону предшествующих кровотечений;
3. госпитализации и переливания крови в связи с ними;
4. приём антиагрегантов, антикоагулянтов и других препаратов;
5. артериальную гипертензию, коагулопатии, анемию;
6. кровотечения у родственников;
7. травмы и операции на полости носа и околоносовых пазухах.

Носовое кровотечение, особенно рецидивирующее, может быть первым проявлением коагулопатии, наследственной геморрагической телеангиэктазии, опухоли полости носа или носоглотки, заболеваний печени или почек. Беспричинное появление синяков и петехий, кровотечения из внутренних органов в анамнезе свидетельствуют в пользу системного нарушения свёртывания крови.

Повышают риск кровотечения

1. антикоагулянты: варфарин, гепарин, дабигатран, апиксабан и другие;
2. антиагреганты: ацетилсалициловая кислота, клопидогрел;
3. многие назальные спреи, в том числе сосудосуживающие и глюкокортикостероидные;
4. некоторые наркотические вещества.

Кровотечение на фоне антикоагулянтов или антиагрегантов может потребовать их отмены или снижения дозы; у таких пациентов чаще рецидивы и кровопотеря более 250 мл, требующая переливания крови.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается при подтверждении кровянистых выделений из носа данными риноскопии и фарингоскопии.

3.1 Осмотр оториноларинголога

Каждого пациента с носовым кровотечением осматривает оториноларинголог: оценивает общее состояние, ищет источник кровотечения и определяет тактику лечения.

При необходимости госпитализации следует выбирать стационар, в котором имеется дежурный оториноларинголог. Если во время кровотечения пациент не был осмотрен оториноларингологом, в том числе в связи с самопроизвольной остановкой кровотечения, необходима плановая консультация оториноларинголога.

3.2 Оценка гиповолемии

У всех пациентов оценивают пульс и уровень сознания, осматривают кожу и доступные слизистые оболочки.

Диагностические признаки гемодинамических нарушений вследствие кровопотери

1. обморок;
2. тахикардия;
3. тахипноэ;
4. бледность кожных покровов и слизистых оболочек.

Кровоизлияния на коже и слизистых оболочках при отсутствии травмы могут указывать на системное нарушение свёртывания крови.

Показания к поиску телеангиэктазий на слизистой оболочке носа и рта

1. повторные кровотечения из обеих половин носа;
2. носовые кровотечения у родственников.

Цель: исключение наследственной геморрагической телеангиэктазии (болезни Рандю—Ослера—Вебера).

3.3 Измерение артериального давления

Показания

1. все пациенты.

Диагностические признаки

1. артериальная гипертензия;
2. артериальная гипотензия может свидетельствовать о значительной кровопотере.

3.4 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки

Показания

1. источник кровотечения не визуализируется при передней риноскопии.

При трудно контролируемом кровотечении эндоскопическое исследование может проводиться в операционной: это позволяет аспирировать кровь и одновременно воздействовать на источник кровотечения.

Повторяющееся одностороннее кровотечение может быть первым признаком опухоли, не визуализируемой при передней риноскопии, а у детей также инородного тела. Если выполнить эндоскопию в момент кровотечения невозможно, её проводят в отсроченном периоде, о чём пациенту дают соответствующую рекомендацию.

3.5 Общий анализ крови

Показания

1. пациенты с носовым кровотечением.

Исследование позволяет оценить выраженность постгеморрагической анемии и тромбоцитарный гемостаз.

Диагностические признаки

1. о кровопотере судят по уровню гемоглобина и гематокриту (таблица ниже).

Степень кровопотери у взрослых

Степень	Объём кровопотери	Гемоглобин, г/л	Гематокрит, %
I	до 500 мл	более 120	более 40
II	500–1000 мл	100–120	30–40
III	1000–1500 мл	80–100	20–30
IV	более 1500 мл	менее 80	менее 20

3.6 Коагулограмма

Международное нормализованное отношение (МНО), фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время.

Показания

1. рецидивирующие кровотечения;
2. кровотечение, требующее госпитализации.

У пациентов, получающих варфарин, МНО **выше 4,5** прогностически неблагоприятно.

На фоне приёма прямых пероральных антикоагулянтов (дабигатран, ривароксабан и др.) эти показатели могут не отражать степень гипокоагуляции.

3.7 Консультации специалистов

Консультация терапевта или педиатра

1. артериальная гипертензия;
2. анемия;
3. коагулопатия;
4. другие сопутствующие заболевания, влияющие на течение кровотечения.

Консультация гематолога

1. рецидивирующие кровотечения и лабораторные признаки тромбоцитопатии или коагулопатии.

---

4. Лечение

Целью лечения является остановка кровотечения, устранение факторов риска и коррекция последствий кровопотери, в том числе гиповолемии и анемии.

Если кровотечение не угрожает жизни, его в первую очередь останавливают местными методами:

1. прижатие крыльев носа;
2. сосудосуживающее средство;
3. коагуляция;
4. тампонада.

Корригировать гемостаз или отменять антикоагулянты и антиагреганты следует лишь после этого: системная коррекция сопряжена с риском осложнений, прежде всего тромбоэмболических.

4.1 Остановка кровотечения: порядок действий

1. Прижатие крыльев носа к носовой перегородке **на 5 минут и более**, как правило **на 5–15 минут**. Предварительно пациент сморкается для удаления сгустков, сидит или стоит с небольшим наклоном головы вперёд; манипуляцию может выполнить сам пациент. Если кровь продолжает стекать, источник, вероятнее всего, расположен глубже.
2. Источник установлен, кровотечение продолжается: аппликация на источник турунды с сосудосуживающим средством (взрослым); взрослым и детям возможна аппликация гемостатического средства.

   Сосудосуживающие средства у взрослых

   1. однократно на турунде: #ксилометазолин или #эпинефрин;
   2. #оксиметазолин, спрей: по 2 впрыскивания в каждую половину носа 3 раза в сутки, 3–5 дней.

   Пометка off-label (в КР — знак #) обозначает применение вне инструкции.

   При артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца (ИБС) и ишемии головного мозга сосудосуживающие препараты применяют с осторожностью.

   Аппликация гемостатического средства на турунде (однократно)

   1. взрослые: #транексамовая кислота, 5 мл на кусочек ваты или марли, на источник кровотечения **на 10–30 минут**;
   2. взрослые и дети: этамзилат.
3. Источник установлен, кровотечение продолжается: коагуляция кровоточащего сосуда.
   Коагуляция может выполняться химическим методом (нитратом серебра), электрокоагуляцией, лазером или радиоволновым методом. Предварительная аппликация сосудосуживающего средства повышает эффективность коагуляции.
4. Источник обнаружить не удаётся: передняя тампонада полости носа.
   Рассасывающиеся материалы (например, коллагеновая гемостатическая губка) не требуют обязательного удаления из полости носа, что является их преимуществом перед

нерассасывающимися тампонами.

При удалении тампона существует риск возобновления кровотечения. Поэтому при высоком риске повторных кровотечений (наследственная геморрагическая телеангиэктазия, заболевания крови) предпочтительны рассасывающиеся материалы.

Длительность тампонады зависит от соматического состояния пациента и вида тампона.

Среди нерассасывающихся тампонов преимуществами обладают баллонные, заполняемые воздухом или жидкостью: давление на стенки полости носа можно регулировать, а низкая адгезия к слизистой оболочке снижает риск рецидива кровотечения при удалении тампона.

У детей источник кровотечения, как правило, находится в передних отделах носа. Если позволяет поведение ребёнка, предпочтительны щадящие бестампонные методы остановки. Если ребёнок психологически не готов к манипуляциям, предпочтение также отдают передней тампонаде.

5. Кровотечение из задних отделов не останавливается передней тампонадой: сочетанная передняя и задняя тампонада с установкой тампона в области хоан и носоглотки.

   Пациенты с задним тампоном подлежат наблюдению и лечению в стационаре. Нить или фиксатор не должны оказывать избыточного давления на крыло носа во избежание образования пролежня. Ряд авторов указывает на необходимость системной антибактериальной терапии при задней тампонаде.

   Более удобны, особенно у детей, специализированные баллонные тампоны для носоглотки с фиксатором, заполняемые воздухом или жидкостью.

6. Коагуляция или механическая остановка неэффективны при продолжающемся или рецидивирующем кровотечении: рассматривается эндоваскулярная эмболизация сосудов или хирургическая перевязка артерии.

   В редких случаях перевязывают наружную сонную артерию на стороне кровотечения. Эффективность эмболизации достигает 87%, однако осложнения при ней развиваются чаще, чем при перевязке; эмболизация может выполняться под седацией и без удаления тампонов.

Ограничения методов остановки кровотечения

1. электрокоагуляция с двух сторон повышает риск перфорации перегородки носа;
2. лазерная фотокоагуляция применима только в «сухом поле», при продолжающемся кровотечении не используется.

Перевязка наружной сонной артерии может приводить к усилению кровотечения за счёт множества коллатералей между наружной и внутренней сонными артериями.

При рецидивирующих кровотечениях из зоны Киссельбаха рекомендуется отслойка слизистой оболочки перегородки носа.

Показания к отслойке при визуально расширенных сосудах зоны Киссельбаха

1. не удаётся идентифицировать конкретный сосуд для коагуляции;
2. кровотечение начинается из различных точек зоны Киссельбаха.

Противопоказания

1. признаки субатрофии слизистой оболочки;
2. выраженное искривление перегородки носа.

Область отслойки ограничивают зоной расширенных сосудов в переднем отделе перегородки носа.

4.2 Медикаментозная терапия

Повышенное артериальное давление требует антигипертензивной терапии, которая позволяет уменьшить кровопотерю и риск рецидива.

При недостаточной эффективности первичных мероприятий применяют гемостатические средства в дозах согласно инструкции:

1. транексамовая кислота: внутривенно **с 1 года**, в таблетках **с 3 лет**;
2. аминокапроновая кислота;
3. аминометилбензойная кислота;
4. этамзилат.

При продолжающемся кровотечении предпочтительно внутривенное введение, таблетированные формы используют для профилактики рецидивов.

Системное применение этамзилата оправдано только при диапедезном кровотечении из мелких сосудов слизистой оболочки.

При травматическом кровотечении или риске тяжёлого кровотечения пациентам старше года вводят транексамовую кислоту внутривенно в максимально ранние сроки, предпочтительно **в первые 3 часа** после травмы.

Ведение пациентов с коагулопатиями и переливание крови по возможности осуществляются совместно с гематологом, терапевтом или педиатром.

Детям с геморрагическим синдромом при дефиците витамина К вводится менадиона натрия бисульфит; допустимо и профилактическое введение, не дожидаясь подтверждения дефицита.

1. новорождённые: до 4 мг в сутки;
2. дети от 1 месяца до 1 года: 2–5 мг в сутки.

После кровотечения или его остановки рекомендуются увлажняющие и ранозаживляющие средства для слизистой оболочки полости носа.

Эти средства уменьшают сухость и образование корок, что позволяет пациенту избегать самостоятельного туалета носа; применяют их и при субатрофическом рините.

---

5. Профилактика. Показания к госпитализации

Пациентам разъясняются факторы риска повторного кровотечения, способы его самостоятельной остановки и показания для обращения к врачу.

Разъясняют

1. детям, родителям и пожилым пациентам: недопустимость пальцевой травмы слизистой оболочки носа;
2. пожилым: связь риска кровотечения с приёмом лекарственных препаратов и подъёмом артериального давления.

Для профилактики рецидивов учитывают

1. факторы сухости слизистой оболочки полости носа: применение кислородных канюль и дыхательных аппаратов повышенного давления;
2. контроль МНО у пациентов, получающих варфарин (обязателен);
3. возникновение кровотечения на фоне назальных спреев: дозу уменьшают и разъясняют пациенту правильную технику применения.

Показания к немедленному обращению за неотложной помощью (информация для пациента)

1. сильное кровотечение;
2. кровотечение **дольше 15 минут**;
3. слабость или головокружение.

Самостоятельная остановка кровотечения (информация для пациента)

1. наклониться вперёд и зажать крылья носа минимум **на 5 минут**, при продолжающемся кровотечении удерживать **полные 15 минут**;
2. высморкаться, распылить 2 дозы сосудосуживающего спрея в кровоточащую половину носа и прижимать крыло носа ещё 5 минут, однократно можно повторить;
3. допустим ватный тампон, смоченный сосудосуживающим спреем;
4. кровь, стекающую в глотку, не глотать, а сплёвывать;
5. если кровотечение не прекращается, обратиться к врачу.

Режим после вмешательства по остановке кровотечения

1. избегать сморкания, физических нагрузок, поднятия тяжестей, закладывания в нос ватных дисков или салфеток минимум **в течение недели**;
2. допустимы физиологический раствор натрия хлорида или увлажняющие средства для носа 1–3 раза в день.

Если кровотечения возникают на фоне препаратов, снижающих свёртываемость крови, необходима консультация назначившего их врача о коррекции лечения. При сильном кровотечении дополнительные дозы таких препаратов не принимают до осмотра, который не следует откладывать.

Если кровотечение связано с повышением артериального давления, для подбора антигипертензивной терапии пациента направляют к терапевту, педиатру или кардиологу.

5.1 Показания к госпитализации

Решение о госпитализации после передней тампонады учитывает

1. длительность кровотечения;
2. объём кровопотери;
3. признаки гиповолемии;
4. сопутствующие заболевания;
5. тип тампона;
6. доступность амбулаторной помощи.

Активное кровотечение или нестабильная гемодинамика: обследование и лечение в приёмном или оториноларингологическом отделении.

На фоне гипертонической болезни кровотечение останавливает оториноларинголог в приёмном отделении, после чего пациент госпитализируется в терапевтический стационар для нормализации артериального давления.

При незначительном или остановившемся кровотечении обследование пациента возможно в амбулаторных условиях.

Показания к госпитализации

1. неэффективность первичных мероприятий;
2. значительная кровопотеря или интенсивное кровотечение;
3. признаки гиповолемии;
4. тяжёлая сопутствующая патология;
5. высокий риск рецидива.

Госпитализация обязательна, если нужны

1. переливание крови;
2. задняя тампонада;
3. перевязка сосудов;
4. эмболизация;
5. передняя тампонада нерассасывающимся материалом, если удалить тампоны амбулаторно невозможно.

Критерии значительной кровопотери и интенсивного кровотечения

1. значительная кровопотеря: **более 10%** объёма циркулирующей крови (около 500 мл у взрослого);
2. интенсивное кровотечение: **более 1 мл/кг в минуту**.

По данным аудита в Великобритании, тяжёлым считается кровотечение суммарной длительностью **более 30 минут за 24 часа**. Риск тяжёлого кровотечения повышают госпитализации по поводу кровотечений в анамнезе, особенно с переливанием крови, и более трёх эпизодов за последние 3 месяца.

Пациента выписывают при:

1. стойкой остановке кровотечения;
2. отсутствии признаков гиповолемии;
3. стабильной гемодинамике;
4. компенсации сопутствующих заболеваний.

Наблюдение и лечение на амбулаторном этапе проводит оториноларинголог.

Исход во многом определяется скоростью и объёмом кровопотери: массивная кровопотеря более 40% объёма циркулирующей крови может быть несовместима с жизнью.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Носовое кровотечение»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 08.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	977_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных расхождений не выявлено.

Клинические рекомендации

ОРВИ у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B34.0** — Аденовирусная инфекция неуточненная **B34.2** — Коронавирусная инфекция неуточненная **J00** — Острый назофарингит (насморк) **J04.1** — Острый трахеит **J06.0** — Острый ларингофарингит **J06.8** — Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации **J06.9** — Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная **J39.9** — Болезнь верхних дыхательных путей неуточненная
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 02.09.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Союз педиатров России; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии; Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/25_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- ОРВИ является самой частой острой инфекцией дыхательных путей и в большинстве случаев проходит самостоятельно. Клиническая картина практически не зависит от возбудителя, лечение направлено на облегчение симптомов. Изменение цвета слизи из носа на жёлто-зелёный не является признаком бактериальной инфекции.
- Детям с ринитом и лихорадкой показана отоскопия. Рентгенография пазух **в первые 10–14 дней** при отсутствии признаков бактериального синусита не рекомендуется. Бактериальный синусит следует заподозрить при заложенности **более 7 дней** и второй волне температуры; отит развивается, как правило, **на 2–5-е сутки**.
- Лечение симптоматическое:
  1. промывание носа солевыми растворами;
  2. сосудосуживающие препараты **не более 5 дней**;
  3. при лихорадке парацетамол или ибупрофен (оба **с 3 месяцев**).

  Антибиотики при неосложнённой ОРВИ не назначают, в том числе при риносинусите, ларингите, крупе, бронхите **в первые 10–14 дней**.
- Госпитализации подлежат дети **до 3 месяцев** с фебрильной лихорадкой и дети любого возраста с опасными признаками:
  1. отказ от питья, вялость;
  2. дыхательная недостаточность, цианоз;
  3. тяжёлое обезвоживание;
  4. фебрильная лихорадка **более 4–5 суток**, рефрактерная к жаропонижающей терапии;
  5. геморрагический синдром.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

ОРВИ — самая частая острая инфекция дыхательных путей; в большинстве случаев проходит сама и специфического лечения не требует.

Проявления катарального воспаления

1. лихорадка;
2. ринит, чихание;
3. кашель;
4. боль в горле, осиплость;
5. нарушение общего состояния.

Нозологические формы

1. острый ринофарингит;
2. острый фарингит;
3. острый трахеит;
4. острая инфекция верхних дыхательных путей неуточнённая.

ОРИ без установленной этиологии (вирусная и (или) бактериальная) раньше называли ОРЗ.

2.2 Этиология

Возбудителями ОРВИ являются преимущественно вирусы. Одновременно циркулируют десятки возбудителей, но клиническая картина от этиологии почти не зависит, поэтому диагноз должен отражать нозологическую форму.

Передача происходит чаще самоинокуляцией на слизистую носа или конъюнктиву с загрязнённых рук и поверхностей, а также воздушно-капельно. Инкубация **2–7 дней**; пик выделения вируса на 3-и сутки, слабое выделение **до 2 недель**.

Симптомы являются реакцией иммунной системы; цвет назального секрета меняется на бело-жёлтый или зеленоватый из-за лейкоцитов, поэтому считать его признаком бактериальной инфекции безосновательно. «Вирусно-бактериальная» ОРИ практикой не подтверждается: бактериальные осложнения редки.

Основные возбудители

Возбудитель	Особенности
Риновирус	25–40% ОРВИ, круглый год с подъёмами весной и осенью, чаще дети до 5 лет; ринит, бронхит, провоцирует бронхообструкцию и обострения астмы; выделение вируса 5–10 дней
Аденовирус	поражает дыхательные пути, лимфоидную ткань, конъюнктиву, кишечник; устойчив во внешней среде до 2 недель; до 6 месяцев защищают материнские антитела; вспышки в коллективах
Респираторно-синцитиальный вирус	высококонтагиозен, иммунитет нестойкий; у детей до 2 лет — бронхиолит с дыхательной недостаточностью; есть пассивная иммунизация для групп риска
Метапневмовирус	от лёгких форм до бронхита, бронхиолита, пневмонии; пик зимой и ранней весной
Грипп	антигенная изменчивость; ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит; тяжёлое течение с пневмонией и ОРДС; есть вакцинация
Парагрипп	у маленьких детей может давать «ложный круп» (острый обструктивный ларингит); иммунитет нестойкий
Сезонные коронавирусы	до 30% сезонных ОРВИ у детей; инкубация 2–3 дня; ринит, фарингит, сухой кашель, диарея
Бокавирус	ринофарингит, иногда обструктивный бронхит, может ухудшать астму

2.3 Степени тяжести

Температура не отражает тяжесть: опасные состояния бывают и без лихорадки. Главной задачей является стратификация риска, особенно у детей с тяжёлой сопутствующей патологией.

Степени тяжести

1. лёгкая: слабая интоксикация, неяркие местные изменения;
2. среднетяжёлая: умеренная интоксикация (головная боль, слабость, снижение аппетита), возможен абдоминальный синдром;
3. тяжёлая: выраженное нарушение общего состояния, многократная рвота, изменения сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения, возможны бред, судороги.

Признаки особой тяжести: судорожный, менингеальный, геморрагический синдромы, признаки энцефалита, гипотермия.

2.4 Клиническая картина

Начало острое, чаще субфебрилитет (**37,5–38,0 °C**).

Фебрильная лихорадка характернее для

1. гриппа;
2. аденовирусной инфекции;
3. энтеровирусных инфекций.

У 82% температура снижается **на 2–3-й день**, при гриппе и аденовирусной инфекции держится **до 5–7 дней**.

Признаки бактериальной инфекции и осложнений

1. нарастание температуры и признаки бактериальной интоксикации указывают на бактериальную инфекцию;
2. повторный подъём после улучшения часто связан с острым средним отитом на фоне ринита.

При лихорадке может быть трудно вовремя распознать бактериальную инфекцию; чаще она встречается у детей **младше 1 года**.

1. ринофарингит: заложенность, выделения, жжение и сухость в носоглотке, стекание слизи с кашлем и чиханием; пик **на 1–3-й день**, длительность **до 6–8 дней**; при евстахеите щелчки, шум, боль в ушах, снижение слуха; у грудных — беспокойство, трудности кормления и засыпания;
2. ларингит: осиплость, грубый сухой кашель; в отличие от крупа нет стеноза и дыхательной недостаточности;
3. фарингит: гиперемия, отёчность и зернистость задней стенки глотки, непродуктивный навязчивый кашель;
4. трахеит: навязчивый изнуряющий кашель, затем влажный; **до 10–14 дней**.

2.5 Осложнения

1. острый синусит, чаще бактериальный: заложенность носа **более 7 дней**, вторая волна температуры, тяжесть в голове, головная боль;
2. острый средний отит: постоянные или пульсирующие (стреляющие) боли в ухе, возможна болезненность в области сосцевидного отростка. Катаральный отит особенно часто развивается при рините и РС-инфекции, как правило, **на 2–5-е сутки** назофарингита у детей раннего возраста (до 20–40%), но гнойный отит, требующий антибиотиков, возникает далеко не у всех (тактика — по КР «Острый средний отит»);

1. острый бронхит: длительный продуктивный кашель;
2. пневмония: температура **38,0 °C и выше** **более 3 дней**; при гриппе до 12% детей;
3. бактериемия: около 1% при РСВ, 6,5% при энтеровирусах;
4. обострение хронических болезней: астмы, инфекции мочевых путей.

2.6 Исходы и прогноз

Без осложнений ОРВИ скоротечна, выделения из носа и кашель могут держаться 1–2 недели. Мнение, что частые ОРВИ — признак «вторичного иммунодефицита» или переходят в хронические болезни, безосновательно.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Общепринятых критериев нет. Диагноз устанавливается по жалобам, анамнезу, данным осмотра и эпидемиологического анамнеза; обследование нацелено прежде всего на выявление осложнений, выбор тактики и маршрутизацию.

Катаральное воспаление верхних дыхательных путей, возможны

1. лихорадка;
2. чихание, кашель;
3. боль в горле, осиплость;
4. нарушение обоняния.

В диагнозе следует избегать изолированного термина «ОРВИ» и указывать нозологическую форму: «острый назофарингит», «острый ларингофарингит», «острый фарингит».

3.2 Жалобы и анамнез

В анамнезе уточняют

1. контакт с больными, заболеваемость в детском учреждении, эпидемический подъём, сезон;
2. характер и длительность жалоб: недомогание, лихорадка, у грудных — отказ от груди, беспокойство; боль в горле, насморк, осиплость, кашель, лимфоузлы, боли в животе;
3. при осложнениях: одышка, сердцебиение, сильная головная боль, рвота, судороги, потеря сознания;
4. переносимость температуры, фебрильные судороги в анамнезе, динамику симптомов;
5. хронические заболевания — риск осложнений;
6. прививки (у детей **до 6 месяцев** — и вакцинацию матери), пассивную иммунизацию против РСВ у детей из групп риска.

3.3 Осмотр, аускультация и пальпация

При осмотре всех пациентов с подозрением на ОРВИ оценивают

1. кожу и слизистые оболочки, склеры;
2. нёбные дужки и заднюю стенку глотки (гиперемия, зернистость, фолликулы);
3. миндалины;
4. регионарные лимфоузлы.

Те же признаки встречаются при стрептококковом тонзиллофарингите.

Физикальное обследование всем пациентам с подозрением на ОРВИ

1. частота сердечных сокращений и аускультация сердца — для выявления миокардита, кардиомиопатии, эндокардита, нарушений ритма;
2. пальпация и аускультация лёгких — для выявления бронхита, бронхообструкции, пневмонии;
3. осмотр и пальпация живота — для выявления поражения ЖКТ, гепатоспленомегалии (инфекционный мононуклеоз).

Пальпация и аускультация грудной клетки определяют уровень поражения дыхательных путей: бронхит, бронхообструкция, локальная симптоматика пневмонии.

При осмотре и пальпации живота: при аденовирусной инфекции возможны тошнота, рвота, диарея; гепатомегалия со спленомегалией или без неё возможна при инфекционном мононуклеозе.

При головной боли, вялости, сонливости проверяют менингеальные симптомы: инфекции ЦНС (в том числе корь) могут начинаться с катаральных симптомов.

При лихорадке, рвоте, диарее оценивают степень обезвоживания по шкале CDS. На каждый 1 °C повышения температуры потери жидкости и электролитов растут примерно на 10%.

Шкала дегидратации CDS

Признак	0 баллов	1 балл	2 балла
Внешний вид	нормальный	жажда, беспокойство, раздражительность	вялость, сонливость, слабость
Глаза	нормальные	слегка запавшие	запавшие
Слизистые оболочки	влажные	липкие	сухие
Слёзы	слезоотделение в норме	слезоотделение снижено	слёзы отсутствуют

Оценка суммы баллов

1. **0 баллов**: дегидратации нет;
2. **1–4 балла**: лёгкая дегидратация;
3. **5–8 баллов**: дегидратация средней и тяжёлой степени.

3.4 Отоскопия

Показания

1. дети с ОРВИ, ринитом и лихорадкой: отоскопия по возможности, чтобы своевременно выявить отит.

3.5 Экспресс-тесты и ПЦР

Показания

1. подозрение на острый стрептококковый тонзиллит: экспресс-тест на БГСА в мазке из зева.

Показания

1. высокая лихорадка и подозрение на грипп: ПЦР на РНК вирусов гриппа A и B в мазке из носоглотки или иммунохроматографический экспресс-тест для своевременного противовирусного лечения.

Инкубационный период при дифференциальной диагностике (приложение А3.2, табл. 6)

1. **грипп**: начало острое, 12–48 часов;
2. **COVID-19**: 2–14 дней, чаще 5–7 дней;
3. **РС-вирусная инфекция**: 3–7 дней;
4. **ОРВИ неуточнённая**: 1–13 дней, чаще 2–3 дня (аденовирусная инфекция до 13 дней).

ПЦР выявляет вирус в среднем **до 7 дней**, максимум **до 2 недель** от начала; результат **через 4–6 часов**.

Диагноз

1. в эпидемию диагноз «грипп» допустимо устанавливать клинически;
2. без возможности этиологической диагностики — «гриппоподобное заболевание».

Селективно, чаще в стационаре: экспресс-тесты на аденовирус, РСВ, метапневмовирус, парагрипп, риновирусы, бокавирус, SARS-CoV-2 или ОТ-ПЦР в реальном времени на возбудителей ОРИ.

Для ПЦР берут мазок из носоглотки; определяют тех же возбудителей.

Выявление вируса не всегда означает его роль (носительство); рутинная верификация сомнительна, нужна у иммунокомпрометированных.

3.6 Общий анализ крови, С-реактивный белок, анализ мочи

Показания

1. выраженные общие симптомы и лихорадка: развёрнутый общий анализ крови;
2. в стационаре: всем пациентам.

Повышение маркеров воспаления является поводом искать «немую» пневмонию, отит, инфекцию мочевых путей. Лейкопения характерна для гриппа и энтеровирусов; при РСВ возможен лимфоцитарный лейкоцитоз выше 15×10^9/л, при аденовирусе лейкоцитоз 15–20×10^9/л и выше, СРБ выше 30 мг/л. Повторный анализ после выздоровления нецелесообразен.

Синдром системной воспалительной реакции у детей: пороги по возрасту (приложение А3.4, табл. 7)

1. **0–7 дней**: ЧДД более 50, ЧСС более 180 или менее 100, лейкоциты более 34×10^9/л, САД менее 65 мм рт. ст.;
2. **7 дней – 1 месяц**: ЧДД более 40, ЧСС более 180 или менее 100, лейкоциты более 19,5 или менее 5×10^9/л, САД менее 75;
3. **1 месяц – 1 год**: ЧДД более 34, ЧСС более 180 или менее 90, лейкоциты более 17,5 или менее 5×10^9/л, САД менее 100;
4. **2–5 лет**: ЧДД более 22, ЧСС более 140, лейкоциты более 15,5 или менее 6×10^9/л, САД менее 94;
5. **6–12 лет**: ЧДД более 18, ЧСС более 130, лейкоциты более 13,5 или менее $4,5\times10^9$/л, САД менее 105;
6. **13–18 лет**: ЧДД более 16, ЧСС более 110, лейкоциты более 11 или менее $4,5\times10^9$/л, САД менее 117.

Маркеры системной воспалительной реакции (табл. 8): нейтрофилез более 7,73–10×10^9/л, С-реактивный белок более 30–37 мг/л, прокальцитонин более 0,5–0,95 нг/мл.

Показания

1. лихорадка **выше 38 °С**, особенно без видимого очага: С-реактивный белок определяют селективно.

Уровень **выше 50 мг/л** характернее для бактериальной инфекции (точки отсечения в литературе 40–100 мг/л); его оценивают вместе с клинической картиной и в динамике.

В первые **12 часов** лихорадки низкий СРБ бактериальную инфекцию не исключает. СРБ может быть низким также при заболеваниях печени и иммунодефиците. Прокальцитонин рутинно не показан.

Показания

1. подозрение на инфекцию мочевых путей, в том числе у лихорадящих детей без катаральных явлений: общий анализ мочи (возможно тест-полосками).

У 5–10% детей раннего возраста с инфекцией мочевых путей есть и вирусная ко-инфекция с картиной ОРВИ. Детям с назофарингитом или ларингитом без лихорадки анализ мочи выполняют только при жалобах или патологии мочевой системы.

3.7 Рентгенография

Рентгенография пазух при остром рините или ринофарингите **в первые 10–14 дней** без признаков бактериального синусита не рекомендуется: ранняя рентгенография часто выявляет вирусное воспаление пазух, которое регрессирует самостоятельно за 2 недели.

Рентгенография и КТ лёгких каждому ребёнку с ОРВИ не рекомендуются из-за лучевой нагрузки. Усиление бронхососудистого рисунка и расширение корней недостаточны для диагноза пневмонии и не являются показанием к антибиотикам.

В сомнительных случаях, а также при подозрении на COVID-19 возможна спиральная КТ лёгких.

3.8 Пульсоксиметрия, ЭКГ, ЭЭГ

При признаках дыхательной недостаточности показана пульсоксиметрия.

ЭКГ и (или) эхокардиография показаны при

1. подозрении на нарушения ритма или миокардит;
2. тяжёлой и осложнённой ОРВИ;
3. пороках сердца, кардиомиопатии или миокардите в анамнезе.

При неврологической симптоматике (декомпенсация фоновой патологии, афебрильные судороги, подозрение на отёк мозга, менингит, энцефалит) ЭЭГ выполняют селективно.

3.9 Консультации специалистов

При подозрении на отит или синусит показан осмотр оториноларинголога.

Консультации по показаниям

1. невролог: нейроинфекция;
2. детский гематолог: выраженные изменения крови, геморрагический синдром;
3. детский кардиолог: миокардит, сердечная недостаточность.

---

4. Лечение

Важно объяснить родителям доброкачественный характер болезни, ожидаемую длительность симптомов и достаточность минимальных вмешательств. Основу лечения составляет облегчение симптомов. Противовирусное лечение не входит в рутинное: оно разработано только для гриппа.

4.1 Ринит и боль в горле

Показания

1. ринит: несколько раз в день 0,9% раствор натрия хлорида (**с 2 лет**) или стерильная морская вода.

У младенцев с обильным отделяемым слизь аспирируют отсосом, затем вводят солевой раствор; головной конец приподнимают. Гипертонические растворы могут вызывать неприятные ощущения и боль.

При заложенности носа применяют сосудосуживающие капли или спреи по инструкции, коротким курсом **не более 5 дней**. Системные препараты с деконгестантами крайне нежелательны.

Местные антисептики для горла (спреи, таблетки, пастилки) применяют селективно и с осторожностью: риск резистентности и нарушения микробиома; доказательств недостаточно.

4.2 Лихорадка

Показания

1. здоровые дети **3 месяцев и старше**: температура **выше 38,5 °C** в подмышечной впадине или **выше 39–39,5 °C** ректально;
2. детям **до 3 месяцев**, при хронической патологии и при дискомфорте жаропонижающие назначают и при меньшей температуре.

Препараты

1. парацетамол: до 60 мг/кг в сутки, противопоказан **до 3 месяцев**;
2. ибупрофен: до 30 мг/кг в сутки, противопоказан **до 3 месяцев**.

Правила применения жаропонижающих

1. первую дозу парацетамола дают внутрь;
2. повторную дозу дают только при новом подъёме температуры, строго соблюдая интервал; курсом не давать;
3. не чередовать и не сочетать жаропонижающие;
4. ректально только при рвоте или непереносимости приёма внутрь;
5. любая лихорадка у младенца **до 3 месяцев** требует тщательного обследования и направления к специалисту или в стационар.

Жаропонижающие вместе с антибиотиками могут маскировать неэффективность последних.

Физическое охлаждение применяют селективно и с осторожностью: ребёнка раскрывают, обтирают водой 25–30 °C; при «белой» лихорадке не применять.

Не применяют для снижения температуры

1. «литические смеси»: гипотермия, постуральная гипотензия;
2. системные кортикостероиды: иммуносупрессия, жизнеугрожающие осложнения;
3. ацетилсалициловую кислоту;
4. нимесулид;
5. метамизол натрия рутинно: риск агранулоцитоза; только в исключительных случаях однократно, если нет альтернативы.

Жаропонижающие и противосудорожные для профилактики фебрильных судорог не назначают; родителей учат распознавать судороги.

Системные кортикостероиды для снижения температуры не назначают: подавляют воспалительный ответ, иммуносупрессия, при многих инфекциях — жизнеугрожающие осложнения.

Ацетилсалициловую кислоту детям для снижения температуры не применяют — высокий риск нежелательных реакций.

Нимесулид детям для снижения температуры не применяют.

Метамизол натрия рутинно не используют — риск агранулоцитоза, ранние признаки которого на фоне лихорадки могут остаться незамеченными.

Профилактика фебрильных судорог жаропонижающими или противосудорожными не рекомендуется: побочные эффекты, нет доказательств.

Регидратация

1. лихорадка: адекватная гидратация, прежде всего пероральными солевыми растворами для регидратации (не раствором декстрозы), при невозможности через зонд или внутривенно;
2. лёгкое обезвоживание (возбудимость, жажда): пероральные солевые растворы;
3. невозможность выпаивания, тяжёлое обезвоживание: парентеральная регидратация сбалансированными ионными растворами.

Маленьким детям дают по 0,5–1 чайной ложке, старшим небольшими глотками.

Состав пероральных солевых растворов

1. натрий 50–60 ммоль/л;
2. глюкоза менее 90 ммоль/л;
3. общая осмолярность 200–245 ммоль/л.

Суточная потребность в жидкости по Holliday — Segar

1. до 10 кг: 100 мл/кг;
2. 10–20 кг: 1000 мл + 50 мл на каждый кг свыше 10;
3. более 20 кг: 1500 мл + 20 мл на каждый кг свыше 20;
4. более 40 кг: 1500 мл/м^2 поверхности тела.

При тяжёлой гиповолемии вводят болюс сбалансированного кристаллоида **20 мл/кг за 30–60 минут**, при необходимости **до 3 раз**, оценивая эффект после каждого болюса.

Инфузионная терапия при дыхательной недостаточности и ОРДС

1. объём жидкости ограничивают **до 50%** физиологической потребности;
2. при сохранной функции ЖКТ большую часть жидкости вводят энтерально;
3. стремятся к «нулевому гидробалансу»;
4. у гемодинамически стабильных пациентов рестрикцию титруют начиная с 50% расчётной потребности;
5. при задержке жидкости оправданы петлевые диуретики.

Гипергидратация жизнеугрожающа.

Критерии адекватной тканевой перфузии

1. время наполнения капилляров 2 с;
2. удовлетворительное наполнение пульса на периферических и магистральных артериях;
3. тёплые конечности;
4. почасовой диурез более 1 мл/кг/ч;
5. артериальное давление в пределах возрастной нормы;
6. нормальные концентрации глюкозы и ионизированного кальция в крови.

4.3 Кашель

1. противокашлевые рутинно не назначают; при сухом навязчивом кашле в исключительных случаях допустимы бутамират, леводропропизин или преноксдиазин;
2. трахеит с трудноотделяемой мокротой: муколитики коротко и с осторожностью, особенно **до 2 лет** и при нервно-мышечных болезнях («заболачивание»);
3. муколитики и отхаркивающие не сочетают с противокашлевыми;
4. паровые ингаляции не применяют: риск ожогов, нет пользы;
5. системные антигистаминные не назначают: они неэффективны;
6. аскорбиновую кислоту не назначают.

Муколитики (амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин) и отхаркивающие — селективно при трахеите с трудноотделяемой мокротой.

Отхаркивающие одновременно с противокашлевыми не назначают: подавление кашля ведёт к застою мокроты.

Паровые ингаляции детям не рекомендуются: опасность ожогов, нет доказательств пользы; ВОЗ их не рекомендует.

Системные антигистаминные при ОРВИ не назначают: не уменьшают ринит и кашель.

Аскорбиновую кислоту всем детям с ОРВИ не назначают: явного улучшения нет.

Кашель при ларинготрахеите и фарингите не требует бронходилататоров, муколитиков и ингаляционных глюкокортикоидов (информация для родителей).

4.4 Противовирусные препараты

Показания

1. подозрение на грипп у пациентов групп риска или подтверждённый грипп A и B: в первые **24–48 часов** ингибитор нейраминидазы (осельтамивир или занамивир **с 5 лет**) по инструкции.

На вирусы без нейраминидазы не действуют. При лёгком и среднетяжёлом гриппе без факторов риска и для постконтактной профилактики не применяют. Возможны тошнота, рвота, у занамивира — бронхоспазм.

При гриппе средней тяжести, в том числе у пациентов групп риска, применяют балоксавир марбоксил, детям массой **от 20 кг** по инструкции.

Пациентам **старше 2 лет** с гриппом или ОРВИ неустановленной этиологии селективно назначают умифеновир в первые 24–48 часов.

Распространённые в России противовирусные и иммуномодулирующие препараты не имеют достаточных доказательств: эффект ограничивается сокращением болезни в пределах одного дня. Рутинно их не используют, полипрагмазии избегают.

Препараты с недостаточной доказательной базой (приложение А3.5)

1. азоксимера бромид;
2. альфа-глутамил-триптофан + аскорбиновая кислота + бендазол;
3. имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты;
4. инозин пранобекс;
5. интерферон альфа-2b (топические формы);
6. кагоцел;
7. меглюмина акридонацетат;
8. меглюмина натрия сукцинат;
9. риамиловир;
10. тилорон;
11. энисамия йодид;
12. аффинно очищенные антитела в микродозах (анаферон, рафамин, эргоферон);
13. эуфорбиум композитум.

4.5 Антибактериальная терапия

При неосложнённой вирусной инфекции системные антибиотики не назначают: они не предотвращают бактериальную суперинфекцию, а способствуют её развитию.

Антибиотики не назначают

1. неосложнённая ОРВИ и грипп;
2. **в первые 10–14 дней**: риносинусит, конъюнктивит, ларингит, круп, бронхит, бронхообструктивный синдром.

Могут быть показаны детям с хронической бронхолёгочной патологией (например, муковисцидозом) и иммунодефицитом — по микробиологии мокроты.

4.6 Иное лечение

При остром трахеите с трудноотделяемой мокротой селективно применяют препараты листьев плюща (капли с 2 лет, сироп с грудного возраста), первоцвет + тимьян (таблетки с 12 лет), плющ + тимьян (сироп с 2 лет) или другие растительные средства без противопоказаний.

Ребёнок ест по аппетиту, заставлять не следует; польза обильного питья сомнительна. При лихорадке выше 38 °C дают пероральные солевые растворы, а не раствор декстрозы. Мёд, лимон, травяные чаи являются безопасной альтернативой для облегчения симптомов при отсутствии аллергии.

Гомеопатические средства для лечения ОРВИ у детей не рекомендуются — нет доказательств.

5. Показания к госпитализации. Профилактика

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализации подлежат

1. дети **до 3 месяцев** с фебрильной лихорадкой;
2. дети с любым опасным признаком (см. ниже);
3. дети со сложными фебрильными судорогами (**более 15 минут** и (или) повторно в течение суток) — на весь период лихорадки;
4. лихорадящие дети с подозрением на тяжёлую бактериальную инфекцию: вялость, отказ от еды и питья, снижение мочеотделения, геморрагическая сыпь, рвота (возможна и гипотермия);
5. дети с дыхательной недостаточностью;
6. дети с коморбидной патологией и риском декомпенсации;
7. дети по эпидемическим показаниям.

Опасные признаки

1. неспособность или отказ пить, сосать грудь;
2. сонливость, вялость, отсутствие контакта или резкое беспокойство;
3. респираторный дистресс: одышка, тахипноэ, втяжение уступчивых мест, кряхтящее дыхание, апноэ;
4. центральный цианоз;
5. сердечная недостаточность;
6. тяжёлое обезвоживание;
7. фебрильная лихорадка **более 4–5 суток**, не снижающаяся жаропонижающими;
8. геморрагический синдром: носовое кровотечение, прожилки крови при кашле, геморрагическая сыпь.

Признаки дыхательной недостаточности

1. кряхтящее дыхание, раздувание крыльев носа, кивательные движения;
2. частота дыхания: **до 2 месяцев** **более 60 в минуту**, **2–11 месяцев** **более 50**, **старше 1 года** **более 40**;
3. втяжение нижней части грудной клетки;
4. сатурация **менее 95%** на воздухе.

Коморбидная патология с риском декомпенсации

1. иммунодефицит;
2. онкологические и гематологические болезни, нарушения свёртывания;
3. пороки сердца и аритмии, кардиомиопатия, лёгочная гипертензия;
4. хронические болезни лёгких;
5. болезни ЦНС;
6. эндокринные болезни (сахарный диабет 1 типа);
7. болезни печени, почек, ЖКТ.

Вопрос о госпитализации рассматривают также при осложнённом течении ОРВИ, безуспешности или невозможности амбулаторного лечения. При длительной фебрильной лихорадке, тяжёлых осложнениях и по эпидемическим показаниям лечение проводится в стационаре, по возможности в боксированном или инфекционном отделении.

Организация лечения

1. лечение, как правило, амбулаторное у педиатра или инфекциониста;
2. повторный осмотр при температуре **более 3 дней** или ухудшении;
3. при рините, ринофарингите, ларингите, трахеите без опасных признаков госпитализация нецелесообразна;
4. после простых фебрильных судорог (**до 15 минут**, однократно за сутки) ребёнка осматривают для исключения нейроинфекции, решение о госпитализации индивидуально;
5. в стационаре в среднем 3–7 дней.

Режим общий или при необходимости полупостельный с быстрым переходом на общий после снижения температуры.

Родителям следует обратиться к врачу, если (информация для пациента)

1. ребёнок длительно отказывается от питья;
2. появились раздражительность, необычная сонливость со снижением реакции на контакт;
3. затруднено, шумное или учащённое дыхание, втяжение межрёберных промежутков, яремной ямки;
4. судороги или бред на фоне повышенной температуры;
5. температура более 38,4–38,5 °C сохраняется более 3 дней;
6. заложенность носа без улучшения более 10–14 дней, особенно со «второй волной» температуры или ухудшением состояния;
7. боль в ухе или выделения из уха;
8. кашель более 10–14 дней.

5.2 Профилактика

Меры профилактики

1. мытьё рук;
2. маски;
3. обработка поверхностей и инструментов;
4. изоляция заболевших детей;
5. проветривание.

Правила «3Р»

Руки мыть не менее 30 секунд, рот и нос закрыты маской, расстояние не менее 1,5 м.

Правила «3П»

Избегать плохо проветриваемых помещений, мест скопления людей и близко говорящих людей.

Ежегодная вакцинация против гриппа показана **с 6 месяцев**; вакцинация от гриппа и пневмококка снижает риск острого среднего отита. После ОРВИ прививают, как правило, **через неделю** после выздоровления, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке возможно раньше.

Паливизумаб 15 мг/кг в/м ежемесячно, 5 инъекций, детям групп риска

1. дети **до 6 месяцев**, рождённые на **35-й неделе** и раньше;
2. дети **до 2 лет**, лечившиеся по поводу бронхолёгочной дисплазии в последние 6 месяцев;
3. дети **до 2 лет** с гемодинамически значимыми пороками сердца.

#Паливизумаб также применяют

1. детям, рождённым до 28 недель 6 дней, в первые 12 месяцев жизни;
2. после операций на сердце с искусственным кровообращением или ЭКМО: дополнительная доза;
3. детям до 24 месяцев с врождёнными дефектами иммунитета;
4. по решению консилиума: тяжёлая нервно-мышечная патология, травма ЦНС, аномалии дыхательных путей, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, синдром Дауна, состояние после трансплантации.

Для постконтактной профилактики селективно применяют умифеновир по инструкции; доказательства невысокие.

Причинами рецидивирующих респираторных инфекций (раньше «часто болеющие дети») являются свойства возбудителей, экология, пассивное курение, атопия, хронические болезни.

Профилактика рецидивирующих инфекций

1. селективно лизаты бактерий или пидотимод (**с 3 лет**);
2. достаточное потребление витамина D;
3. селективно пробиотики L. rhamnosus GG и (или) S. salivarius K12 не менее 10^9 КОЕ в сутки 3–6 месяцев;
4. рутинно не используют растительные средства, аскорбиновую кислоту, гомеопатию.

Витамин D и его аналоги назначают для коррекции дефицита и профилактики респираторных инфекций.

L. rhamnosus GG и S. salivarius снижают частоту и длительность респираторных инфекций, в том числе отитов.

Растительные средства, аскорбиновая кислота и гомеопатия для профилактики рецидивирующих ОРВИ рутинно не применяются.

Реабилитация, как правило, не требуется; острые инфекции являются противопоказанием к санаторному лечению. Детям, часто болеющим ОРВИ, селективно проводят реабилитацию и санаторно-курортное лечение; следует избегать курения в окружении, недосыпа и переохлаждения.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 02.09.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2029 года
Код в рубрикаторе	25_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии; Российское общество скорой медицинской помощи
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Одонтогенный остеомиелит челюсти

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K10.2** — Воспалительные заболевания челюстей
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 19.06.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1049_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Остеомиелит челюсти — гнойно-некротическое воспаление всех структур челюстной кости одонтогенного или неодонтогенного происхождения; острый одонтогенный остеомиелит выходит за пределы одного зубо-альвеолярного сегмента.
- Для оториноларинголога: при остеомиелите верхней челюсти с «причинным» премоляром или моляром возможен верхнечелюстной синусит (чаще острый серозный, на фоне хронического — обострение гнойного); показаны консультация оториноларинголога и КТ околоносовых пазух.
- Лечение остеомиелита — в стационаре в неотложном порядке: удаление «причинного» зуба, вскрытие и дренирование очага, антибактериальная терапия; при подострой и хронической стадии — секвестрэктомия, при поражении стенок пазухи — по типу операции Колдуэлла — Люка.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Остеомиелит челюсти — гнойно-некротическое воспалительное заболевание костной ткани челюстной кости (одновременно всех её структурных компонентов) инфекционно-аллергической природы одонтогенного или неодонтогенного происхождения.

Острый одонтогенный остеомиелит — процесс, при котором зона поражения распространяется за пределы входного зубо-альвеолярного сегмента — на пародонт соседних зубов или тело челюсти.

Периостит, в отличие от него, ограничен пределами одного зубо-альвеолярного сегмента.

Верхней границей зубо-альвеолярных сегментов верхней челюсти является дно полости носа и верхнечелюстных синусов.

2.2 Этиология и эпидемиология

Периостит развивается на фоне острого или обострения хронических одонтогенных заболеваний, чаще всего хронического периодонтита, реже пародонтита, перикоронита. Возбудители — условно-патогенная микробиота полости рта: факультативные и строгие анаэробы.

Одонтогенный остеомиелит составляет до 74,2% всех остеомиелитов челюстей; встречается преимущественно у мужчин среднего возраста. У госпитализированных пациентов поражение нижней челюсти — в 85% случаев.

2.3 Классификация

1. **периостит челюсти** — острый (серозный, гнойный — ограниченный, диффузный) и хронический (простой, оссифицирующий, рарефицирующий)
2. **остеомиелит по этиологии** — одонтогенный, гематогенный, травматический (в том числе огнестрельный), контактный
3. **по В. И. Лукьяненко (1968)** — форма — острая, подострая, хроническая, обострение хронической; тяжесть — лёгкая, средняя, тяжёлая; локализация — верхняя, нижняя челюсть; распространённость — ограниченный, распространённый, диффузный

2.4 Клиническая картина

При распространении воспаления в костных структурах верхней челюсти вверх, в верхнечелюстную пазуху, возможно развитие верхнечелюстного синусита.

1. **как правило** — острый серозный синусит
2. **«причинный» премоляр или моляр на фоне хронического одонтогенного или смешанного синусита** — обострение хронического гнойного синусита
3. **тактика** — консультация оториноларинголога и контрольное рентгенологическое исследование околоносовых пазух, при технической возможности — КТ

При локализации процесса в зоне моляров верхней челюсти возможен пристеночный отёк слизистой оболочки альвеолярной бухты в области дна верхнечелюстной пазухи над «причинным» зубом — его расценивают как «муфтообразный» инфильтрат.

---

3. Диагностика

3.1 Жалобы и анамнез

При дифференциальной диагностике учитывают жалобы

1. локализация и характер боли — в области одного «причинного» зуба, нескольких зубов и/или челюсти;
2. иррадиация по ходу ветвей тройничного нерва;
3. подвижность одного, двух или нескольких соседних зубов;
4. отёк слизистой оболочки и околочелюстных мягких тканей;
5. парестезии губы, зубов, кожи анатомической области;
6. ограничение открывания рта.

3.2 Консультации специалистов

Всем пациентам показана консультация челюстно-лицевого хирурга и/или стоматолога-хирурга.

Консультация терапевта — при сопутствующей патологии.

Консультация офтальмолога — при тотальном или субтотальном гнойно-некротическом процессе верхней челюсти с распространением на глазницу.

Консультация невролога — при неврологических нарушениях.

Консультация анестезиолога-реаниматолога — перед операцией под сочетанной анестезией или наркозом и при тяжёлой сопутствующей патологии.

При локализации гнойного процесса в верхней челюсти и признаках верхнечелюстного синусита показана консультация оториноларинголога.

Задачи оториноларинголога

1. оценка состояния ЛОР-органов и уточнение диагноза;
2. определение показаний к пункции верхнечелюстной пазухи;
3. коррекция комплексного, в том числе местного, лечения;
4. согласование со стоматологом протокола лечения для предупреждения осложнений со стороны ЛОР-органов.

3.3 Физикальное обследование

Проводится общеклинический осмотр: кожа, слизистые оболочки, ЧСС, артериальное давление, частота дыхания.

Внешний осмотр.

Пальпация и осмотр органов полости рта.

Определение степени открывания рта.

Перкуссия и определение патологической подвижности зубов на поражённом участке челюсти.

Оценка чувствительности нижней губы и подбородка или верхней губы и подглазничной области на стороне поражения.

3.4 Лучевые и лабораторные исследования

Всем пациентам выполняется рентгенологическое исследование челюстно-лицевой зоны для уточнения «причинного» зуба и характера поражения кости: внутриротовая контактная, окклюзионная рентгенография, обзорная рентгенограмма челюсти, рентгенография черепа.

При остром диффузном периостите, субтотальном или тотальном остром, хроническом и обострении хронического остеомиелита, при технической возможности, выполняется КТ челюстно-лицевой области (КЛКТ или МСКТ челюстей).

При предполагаемом остром субтотальном или тотальном остеомиелите показано УЗИ тканей полости рта.

Перед экстренной операцией выполняется комплекс лабораторных исследований.

У всех пациентов в стационаре проводится микробиологическое исследование отделяемого из лунки «причинного» зуба и свищевых ходов с определением чувствительности к антимикробным препаратам.

Цитологическое и патолого-анатомическое исследование проводится для дифференциальной диагностики со специфическими заболеваниями (актиномикоз, туберкулёз, сифилис), опухолями (саркома Юинга) и опухолеподобными образованиями челюстей.

---

4. Лечение

4.1 Условия лечения

Лечение периостита возможно в стоматологической поликлинике в режиме неотложной помощи — только при отсутствии сопутствующей патологии, нормергическом течении и без рисков осложнений.

Одонтогенный остеомиелит лечится в стационаре в режиме неотложной помощи.

При декомпенсированной сопутствующей патологии или гиперергическом течении — многопрофильный стационар.

4.2 Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство выполняется с учётом патогенеза и фазы гнойно-воспалительного процесса.

Удаление «причинного» зуба — для оттока экссудата из первичного очага.

Обязательное вскрытие и дренирование абсцесса полости рта.

При остром периостите — вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса.

При остром и обострении хронического остеомиелита — вскрытие очага в полости рта с обеих сторон челюсти; при флегмоне или свище — внеротовой или сочетанный доступ.

При подострой стадии и хроническом остеомиелите — секвестрэктомия под сочетанной анестезией или комбинированным эндотрахеальным наркозом.

На верхней челюсти рационально использовать внутриротовые доступы. При осложнении остеомиелита верхней челюсти верхнечелюстным синуситом или секвестрации стенок верхнечелюстной пазухи секвестрэктомию целесообразно выполнять по типу радикальной синусотомии (операция по Колдуэллу — Люку).

При остром серозном периостите, если «причинный» зуб — резец или клык, решается вопрос о его сохранении.

При декомпенсированной сопутствующей патологии и приёме антикоагулянтов удаление зуба отсрочено.

При технических трудностях удаления — отсроченное удаление при обязательном дренировании очага: периостеотомия и «остеоперфорация» в проекции зуба.

4.3 Медикаментозное лечение

Рациональная антибактериальная терапия входит в комплексное лечение.

При назначении соблюдаются рекомендации «СКАТ».

Эмпирическую терапию начинают после дренирования очага, обязательно направляя материал на микробиологическое исследование.

После результатов посева переходят на целенаправленную терапию; длительность определяется динамикой процесса, состоянием и анализами.

При отсутствии динамики схему корректируют, проводят ревизию очага и исключают распространение на соседние клетчаточные пространства.

С дезинтоксикационной целью применяют кровезаменители и перфузионные растворы.

Контроль нутритивного статуса и нутритивная поддержка при хирургическом лечении.

Антикоагулянты — при диффузном остеомиелите верхней челюсти, осложнённом течении, декомпенсированной патологии, с профилактикой ВТЭО.

Антигистаминные средства — для снижения гиперергического фона.

НПВП и анальгетики — для купирования боли.

Гипербарическая оксигенация — при технической возможности; озонотерапия — при вялотекущем и хроническом течении.

Местное лечение раны — по фазам раневого процесса: противомикробные препараты и антисептики, при некрозе — протеолитические ферменты, затем средства, оптимизирующие регенерацию.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Рекомендуется своевременная санация полости рта: выявление и лечение кариеса и его осложнений, воспалительных заболеваний пародонта.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация

1. острый серозный или гнойный периостит при суб- или декомпенсированной сопутствующей патологии;
2. гиперергическое течение воспаления;
3. злокачественные новообразования любой локализации;
4. иммунодефицитные состояния.

Плановая госпитализация

1. подострая фаза и хронический остеомиелит при сформированном секвестре;
2. затяжное, торпидное или прогрессирующее течение хронического остеомиелита с длительным формированием секвестров.

Критерии выписки

1. неосложнённое течение раннего послеоперационного периода, удовлетворительное состояние, боль купируется пероральными средствами, антибиотики можно принимать амбулаторно;
2. перевод в другое учреждение;
3. требование пациента или его законного представителя;
4. несоблюдение предписаний, если это не угрожает жизни.

Помощь оказывается в многопрофильном стационаре с возможностью консультаций терапевта и узких специалистов (невролога, оториноларинголога, офтальмолога): при «причинных» премолярах и молярах возможно развитие одонтогенного верхнечелюстного синусита.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Воспалительные заболевания челюстей. Одонтогенный остеомиелит челюсти»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 19.06.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2029 года
Код в рубрикаторе	`1049_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.

Клинические рекомендации

Ожоги. Ожоги дыхательных путей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**L55** — Солнечный ожог **T20** — Термические и химические ожоги головы и шеи **T21** — Термические и химические ожоги туловища **T22** — Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть **T23** — Термические и химические ожоги запястья и кисти **T24** — Термические и химические ожоги области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу **T25** — Термические и химические ожоги области голеностопного сустава и стопы **T27** — Термические и химические ожоги дыхательных путей **T29** — Термические и химические ожоги нескольких областей тела **T30** — Термические и химические ожоги неуточненной локализации **T31** — Термические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела **T32** — Химические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела **T95** — Последствия термических и химических ожогов и отморожений
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 31.08.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Медицинская профессиональная некоммерческая организация «Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/687_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Ингаляционная травма — повреждение слизистой оболочки дыхательных путей и/или лёгочной ткани в результате воздействия термических и/или токсико-химических факторов. Встречается у 20–30% взрослых, поступивших в ожоговые стационары, и у 40–45% пострадавших с ожогами пламенем.
- **Косвенные признаки ингаляционной травмы**
  1. ожоги лица, шеи, передней поверхности грудной клетки, опаление ресниц, бровей, волосков в носовых ходах;
  2. отёк и покраснение слизистой оболочки рта и глотки;
  3. копоть на слизистой оболочке ротоглотки, в носовых ходах, мокроте;
  4. изменение голоса: дисфония, афония;
  5. признаки дыхательной недостаточности, нарушение сознания.
- Бронхоскопия — наиболее информативный метод диагностики ингаляционной травмы; срок — **не позднее 24 часов** от поступления. При экстренном исследовании обязательно оценивают носовые ходы, носоглотку, ротоглотку и гортань.
- Превентивная интубация трахеи показана при ожогах III степени лица и шеи, ожогах верхних дыхательных путей с поражением гортани и риском обструкции, ингаляционной травме III степени: отёк при ожогах головы и шеи нарастает уже **через 1–3 часа** и делает интубацию крайне сложной.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Ожоги — травма вследствие высокотемпературного, химического, электрического или радиационного воздействия на тело, которое повреждает кожу и подлежащие ткани.

Ингаляционная травма — повреждение слизистой оболочки дыхательных путей и/или лёгочной ткани, возникающее в результате воздействия термических и/или токсико-химических факторов.

2.2 Этиология ингаляционной травмы

1. **термические** — термоингаляционное поражение дыхательных путей
2. **токсико-химические** — острые ингаляционные отравления продуктами горения
3. **термохимические** — смешанные

Наиболее опасными токсическими веществами, ингалируемыми с дымом, являются окись углерода, синильная кислота и её производные, диоксид углерода, хлор, фосген. У маленьких детей описаны поражения верхних дыхательных путей при опрокидывании на голову и верхнюю половину туловища горячих жидкостей.

2.3 Классификация

1. **I степень** — в пределах эпидермиса (эпидермальные, поверхностные)
2. **II степень** — до сосочкового слоя дермы с сохранением дериватов кожи (дермальные, «пограничные»)
3. **III степень** — все слои кожи вплоть до собственной фасции, в ряде случаев с повреждением субфасциальных структур (глубокие)

Ингаляционная травма по локализации

1. поражение верхних дыхательных путей без поражения гортани (полость носа, глотка);
2. поражение верхних дыхательных путей с поражением гортани — до голосовых складок включительно;
3. поражение верхних и нижних дыхательных путей: трахея и бронхи главные, долевые, сегментарные, субсегментарные.

Тяжесть ингаляционной травмы по эндоскопическим критериям

Степень	Эндоскопическая картина трахеобронхиального дерева
Лёгкая (I)	умеренная гиперемия, единичные скопления легко отмываемой копоти в трахее и бронхах, небольшое количество слизистого секрета
Средняя (II)	гиперемия и отёк, большое количество копоти в просвете бронхов и единичные скопления фиксированной копоти, единичные петехии и эрозии в трахее и главных бронхах, обильный секрет с копотью
Тяжёлая (III)	выраженные гиперемия и отёк, рыхлая слизистая оболочка, тотальное наслоение фиксированной копоти до сегментарных бронхов; после отмывания — кровоточивая слизистая с эрозиями или бледно-серая «сухая»; слепки десквамированного эпителия, обтурирующие бронхи

Ожоговая болезнь развивается при общей площади ожогов **более 15–20%** поверхности тела и/или глубоких ожогах **более 10%** (у детей и пожилых — **более 5–10%**).

Периоды ожоговой болезни

1. ожоговый шок — **до 3 суток**, в тяжёлых случаях **до 5 суток**;
2. острая ожоговая токсемия;
3. септикотоксемия;
4. реконвалесценция.

Ожоговый шок может развиться и при ограниченных ожогах, если они сочетаются с ингаляционным поражением дыхательных путей: развивается синдром взаимного отягощения.

Ингаляционная травма тяжёлой степени определяет тяжесть состояния и прогноз и указывается в диагнозе перед локальными ожогами кожи.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз ожога кожи и/или ингаляционной травмы устанавливается на основании жалоб, анамнеза и физикального обследования с исключением другой патологии со схожей клиникой; в большинстве случаев лабораторные и инструментальные исследования для диагноза не требуются.

3.2 Физикальное обследование

1. **правило «девяток»** — у взрослых — для обширных ожогов, полностью занимающих отдельные зоны тела
2. **правило ладони** — при ограниченных ожогах: площадь ладони — примерно 1% поверхности тела
3. **диаграмма Лунда — Браудера** — у детей

1. **I степень** — гиперемия, отёк, тонкостенные пузыри с прозрачной жидкостью; дно пузыря розовое, влажное; болевая чувствительность сохранена
2. **II степень** — толстостенные пузыри или десквамация эпидермиса, дерма ярко-розовая, влажная; болевая чувствительность сохранена или снижена
3. **III степень** — толстый струп, через который могут просвечивать тромбированные вены; дно раны тусклое, белесоватое; болевая чувствительность отсутствует, волоски легко удаляются

Глубину поражения окончательно можно определить только **через 7–10 дней** после травмы.

Признаки ингаляционной травмы и отравления продуктами горения

1. ожоги лица, шеи, передней поверхности грудной клетки, опаление ресниц, бровей, волосков в носовых ходах;
2. отёк и покраснение слизистой оболочки рта и глотки;
3. копоть на слизистой оболочке ротоглотки, в носовых ходах, мокроте;
4. дисфония, афония;
5. признаки дыхательной недостаточности;
6. нарушение сознания, не связанное с заболеванием и травмой ЦНС.

Ожоговый шок в раннем периоде не имеет характерных признаков: больной может быть в сознании, гипотония развивается не сразу. Для начала противошоковой терапии достаточно данных физикального обследования — площади, глубины и локализации ожога, возраста.

Клинические критерии ожогового шока через 6–8 часов после травмы

1. сухость кожи и слизистых оболочек, бледность или мраморность кожи;
2. симптом белого пятна **более 3 с**;
3. гипотермия, тахикардия, снижение АД;
4. олигурия или анурия.

3.3 Лабораторные исследования

Пострадавшим на пожаре и находившимся в задымлённом помещении при возможности исследуют карбоксигемоглобин крови. Уровень, измеренный по прибытии в стационар, не отражает истинной степени интоксикации; при отсутствии оборудования диагностика проводится по клиническим данным.

3.4 Бронхоскопия

Срок выполнения бронхоскопии при признаках поражения дыхательных путей — **не позднее 24 часов** от поступления.

При первичном исследовании, как правило, устанавливают лишь факт ингаляционной травмы (копоть на слизистой оболочке); тяжесть поражения можно оценить **через 1–2 суток**.

Абсолютным противопоказанием к экстренной бронхоскопии является только терминальное состояние.

При экстренной бронхоскопии оценивают

1. носовые ходы, носоглотку, ротоглотку и гортань;
2. гиперемию и отёк, кровоизлияния и эрозии слизистой оболочки;
3. копоть на стенках и в просвете трахеобронхиального дерева и степень её фиксации;
4. вид и степень нарушения проходимости дыхательных путей;
5. выраженность кашлевого рефлекса при местной анестезии.

В заключении отражают состояние верхних и нижних дыхательных путей и степень тяжести поражения по эндоскопическим критериям.

4. Лечение

4.1 Респираторная поддержка

1. **абсолютные показания к интубации и ИВЛ** — дыхательная недостаточность III степени и/или угнетение сознания до сопора и глубже
2. **трахеостомия** — по показаниям, например при необходимости длительной ИВЛ
3. **дыхательная недостаточность I–II степени** — возможна неинвазивная вентиляция, высокопоточная оксигенотерапия

Превентивная интубация трахеи и ИВЛ в экстренном порядке

1. ожоги III степени лица и шеи с риском прогрессирующего отёка мягких тканей;
2. угнетение сознания **менее 8 баллов** по шкале комы Глазго;
3. ожоги кожи III степени **более 40%** поверхности тела;
4. ожоги верхних дыхательных путей с поражением гортани и риском обструкции;
5. термохимическое поражение дыхательных путей тяжёлой степени;
6. ингаляционная травма III степени по данным бронхоскопии.

Быстрое нарастание отёка при ожогах головы и шеи уже **через 1–3 часа** после травмы делает интубацию трахеи или трахеостомию крайне сложной.

У детей — экстренная интубация при

1. PaO_2 **менее 80 мм рт. ст.**;
2. SaO_2 **менее 93–94%**;
3. $PaCO_2$ **более 50 мм рт. ст.**;
4. нарушении нормальной механики дыхания.

4.2 Бронхоскопия и ингаляционная терапия

Санационные бронхоскопии восстанавливают проходимость дыхательных путей и удаляют продукты горения, секрет, десквамированный эпителий; при тяжёлых поражениях — **не менее 1 раза в сутки**. После экстубации или удаления трахеостомы обязательна контрольная бронхоскопия для оценки посттравматических и постинтубационных осложнений.

При ингаляционной травме применяют ингаляции через небулайзер: возможно **в течение 7 суток** введение муколитиков (#ацетилцистеин) и #гепарина натрия, однако эффективность небулайзерного гепарина не доказана. При бронхоспазме применяют селективные бета$_2$-адреномиметики.

4.3 Общие мероприятия

Обезболивание анальгетиками проводится при интенсивности боли **более 3 баллов** по визуально-аналоговой шкале, парентерально, ступенчато: от ненаркотических анальгетиков и НПВП к опиоидам.

Первая помощь

1. при возможности быстрой транспортировки — повязка первой помощи без лекарственных веществ;
2. аэрозоли, мази, масла, красители и присыпки не применяют;
3. обожжённую поверхность охлаждают немедленно, **не позднее 10–15 минут**: при ожогах до 10% поверхности тела — **15–20 минут** холодной водой;
4. лёд нежелателен.

Охлаждение сокращает время перегревания тканей, уменьшает отёк и снимает боль, предупреждает углубление повреждения.

Всем пострадавшим с ожогами кожи, кроме случаев только гиперемии, проводится экстренная профилактика столбняка.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Срочное обращение за помощью или вызов скорой показаны, если

1. площадь ожога **более 5%** поверхности тела;
2. подозрение на глубокий ожог III степени;
3. обожжены глаза, лицо, уши, кисти, стопы, крупные суставы, промежность или половые органы;
4. раны расположены циркулярно на конечностях;
5. поражение электротоком, в том числе молнией;
6. подозрение на ожог дыхательных путей или отравление продуктами горения;
7. ожог у ребёнка или пожилого человека, тяжёлые сопутствующие заболевания.

При признаках общей электротравмы показана госпитализация независимо от объёма поражения; при удовлетворительном состоянии без тяжёлых локальных поражений — на срок **не менее 3 дней**.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	687_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»
Пациенты	Дети и взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Показания к госпитализации и обращению за специализированной помощью сформулированы только в приложении В «Информация для пациента»; в разделе 6 рекомендации их нет.

Клинические рекомендации

Опухоли слюнных желёз у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C06.9** — Рта неуточненное **C07** — Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы **C08** — Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез **D10.3** — Других и неуточненных частей рта **D11** — Доброкачественное новообразование больших слюнных желез
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 27.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/75_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- У детей и подростков 75–80% поражений слюнных желёз доброкачественные; самая частая опухоль — плеоморфная аденома. Раком (карциномой) слюнной железы называют злокачественную эпителиальную опухоль; у детей чаще всего встречается мукоэпидермоидная карцинома.
- **Обследование**
  1. УЗИ слюнных желёз и шейных лимфатических узлов с тонкоигольной аспирационной биопсией (ТАБ) и цитологией — всем;
  2. МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием — при подозрении на злокачественную опухоль;
  3. КТ лицевого черепа — при подозрении на поражение костей; КТ органов грудной клетки — при злокачественной опухоли.
- Лечение хирургическое: опухоль удаляют с выделением и сохранением лицевого нерва под нейрофизиологическим мониторингом, только в специализированном центре; энуклеация недопустима.
- Достаточный край резекции: при низком и промежуточном потенциале злокачественности — **2 мм и более**, при высоком (аденокистозный рак) — **5 мм и более**.
- **Контрольные обследования**
  1. первый год: **каждые 3 месяца**;
  2. до 5 лет: **не реже 1 раза в полгода**;
  3. далее: **не реже 1 раза в год**, при злокачественной опухоли — пожизненно.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Рак слюнной железы (карцинома) — злокачественная эпителиальная опухоль слюнной железы. К большим слюнным железам относят околоушную, подчелюстную и подъязычную, к малым — железы полости рта и ротоглотки.

2.2 Этиология и эпидемиология

Возможные предрасполагающие факторы злокачественных опухолей

1. ионизирующая радиация;
2. ранее проведённая лучевая терапия;
3. хроническая вирусная инфекция.

Этиологические факторы доброкачественных образований неизвестны.

Плеоморфная аденома («смешанная опухоль») — самая частая доброкачественная опухоль: средний возраст 16 лет, девочки болеют в 1,43 раза чаще; околоушная железа поражается в 56%, подчелюстная — в 31%, малые железы — в 3,3% случаев. Злокачественные опухоли составляют 1–8% образований головы и шеи у детей: средний возраст 14 лет, околоушная железа поражается до 72%, малые железы — до 20%. Мукоэпидермоидная карцинома встречается до 53%, ацинарноклеточная — 29%, аденокистозная — 5%.

Инфантильная гемангиома и лимфатические мальформации клинически сходны с опухолями, но относятся к сосудистым аномалиям и рассматриваются в соответствующих клинических рекомендациях.

2.3 Классификация

Гистологическая классификация ВОЗ (5-е изд., 2022): 4 группы

1. ненеопластические эпителиальные поражения;
2. доброкачественные эпителиальные опухоли (плеоморфная аденома, опухоль Вартина и др.);
3. злокачественные эпителиальные опухоли (мукоэпидермоидная, аденокистозная, ацинарноклеточная, секреторная карцинома и др.);
4. мезенхимальные опухоли, специфичные для слюнных желёз (сиалолипома).

Гемангиома, лимфатические мальформации, лимфомы и саркомы из классификации исключены; классификация учитывает типичные перестройки генов для каждого типа опухоли.

Характерные молекулярные изменения

1. **мукоэпидермоидная карцинома** — перестройка CRTC1-MAML2 (40–90%)
2. **ацинарноклеточная карцинома** — перестройка/активация NR4A3 (86%)
3. **аденокистозная карцинома** — перестройка MYB (~80%)
4. **секреторная карцинома** — перестройка ETV6-NTRK3 (более 90%)
5. **рак протоков слюнных желёз** — амплификация HER2 (31%), мутация TP53 (56%)

Первичная опухоль (T), TNM 8-е изд.

1. **T1** — **2 см или менее** без распространения за пределы паренхимы
2. **T2** — **более 2 см, но не более 4 см** без распространения за пределы паренхимы
3. **T3** — **более 4 см** и (или) распространение за пределы паренхимы
4. **T4a** — распространение на кожу, нижнюю челюсть, слуховой проход и (или) лицевой нерв
5. **T4b** — распространение на крыловидные отростки, основание черепа или внутреннюю сонную артерию

Регионарные лимфатические узлы (N)

1. **N1** — один узел на стороне поражения **не более 3 см**
2. **N2** — один узел **более 3 см, но не более 6 см** (N2a), несколько узлов на стороне поражения (N2b), двустороннее или контралатеральное поражение (N2c) — до 6 см
3. **N3** — метастазы **более 6 см**

Группировка по стадиям

Стадия	Сочетание T, N, M
I	T1 N0 M0
II	T2 N0 M0
III	T3 N0 M0; T1–T3 N1 M0
IVA	T1–T3 N2 M0; T4a N0–N2 M0
IVB	любое T N3 M0; T4b любое N M0
IVC	любое T, любое N, M1

2.4 Клиническая картина

Доброкачественные опухоли растут медленно: до установления диагноза нередко проходит около 5 лет. Основная жалоба — пальпируемое образование в околоушно-жевательной области, реже поражение лицевого нерва и боль. Тризм и образование боковой стенки глотки характерны для опухоли глубокой доли околоушной железы.

Злокачественные эпителиальные опухоли — медленно растущие образования околоушно-жевательной области или полости рта с крайне низкой потенцией к метастазированию; диагноз запаздывает в среднем на 8–12 месяцев.

Жалобы при злокачественной опухоли

1. безболезненное узловое образование плотноэластической консистенции, не спаянное с кожей, — 99%;
2. болезненность в области опухоли — 22%;
3. парез лицевого нерва — 7%: крайне неблагоприятный прогностический признак.

Опухоли глоточного отростка околоушной железы, несмотря на медленное течение, рано инфильтрируют слизистую оболочку глотки.

Прогноз

1. мукоэпидермоидная карцинома у детей в 87% случаев имеет низкий и промежуточный потенциал злокачественности;
2. пятилетняя общая выживаемость — 93%, безрецидивная — 82%;
3. рецидив возникает в среднем спустя год и месяц после операции.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Комплекс обследования при злокачественной опухоли

1. анамнез и жалобы;
2. осмотр, пальпация образования, прилежащих тканей и регионарных лимфатических узлов;
3. УЗИ слюнных желёз, мягких тканей лица, лимфатических коллекторов шеи;
4. КТ с контрастированием при подозрении на поражение костей основания черепа или челюсти, при рецидиве;
5. МРТ с контрастированием при Т3–Т4, рецидиве, поражении глоточного отростка, подозрении на интракраниальное распространение;
6. ТАБ под контролем УЗИ с цитологическим исследованием опухоли и подозрительных узлов;
7. рентгенография или МСКТ органов грудной клетки;
8. сцинтиграфия костей скелета при первичной диагностике;
9. патолого-анатомическое исследование операционного материала с иммуногистохимией.

При доброкачественной опухоли

1. анамнез, осмотр и пальпация;
2. УЗИ слюнных желёз, мягких тканей лица и шеи;
3. МРТ с контрастированием при большой опухоли, рецидиве или поражении глоточного отростка;
4. ТАБ под УЗИ;
5. патолого-анатомическое исследование операционного материала.

3.2 Дифференциальная диагностика

Дифференцируют

1. доброкачественные и злокачественные опухоли между собой;
2. врождённые пороки головы и шеи, сосудистые поражения, лимфатические мальформации;
3. воспалительные процессы, актиномикоз, туберкулёз, неспецифические лимфаденопатии, аутоиммунные заболевания;
4. метастазы в околоушные, подчелюстные и верхние югулярные узлы, прежде всего при раке носоглотки, ретинобластоме, лимфоме.

3.3 Жалобы и анамнез. Физикальное обследование

Что уточняют у родителей и ребёнка

1. время появления деформации лица или подчелюстной области и скорость её нарастания;
2. функцию мимической мускулатуры, наличие тризма;
3. онкологические заболевания ребёнка и родственников, вредные воздействия во время беременности, указания на врождённый характер заболевания;
4. место жительства до появления признаков заболевания.

При осмотре оценивают

1. рост, массу тела, физическое развитие;
2. железу при пальпации: подвижность узла, инфильтрацию тканей;
3. размер и подвижность лимфатических узлов шеи;
4. функцию лицевого нерва (парез, паралич), открывание рта (тризм), глотание.

При подозрении на узловое поражение железы педиатр направляет ребёнка в клинику челюстно-лицевой хирургии или детский онкологический центр.

3.4 Лабораторные исследования

При госпитализации

1. общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
2. биохимический анализ крови;
3. коагулограмма;
4. общий анализ мочи;
5. группа крови, резус-фактор и фенотип по антигенам эритроцитов.

3.5 УЗИ и тонкоигольная аспирационная биопсия

Всем пациентам строго рекомендуется УЗИ слюнных желёз и лимфатических узлов шеи с тонкоигольной биопсией образования (и узлов при подозрении на их поражение) и цитологическим исследованием. ТАБ признана минимально инвазивным и эффективным методом верификации.

Заключение цитолога по Миланской системе (MSRSGC) с указанием риска злокачественности

1. недиагностический материал;
2. неопухолевый процесс;
3. атипия неуточнённой значимости;
4. подозрение на злокачественное образование;
5. злокачественное образование, по возможности со степенью (low grade, high grade).

Толстоигольная (core) биопсия

1. опухоли малых слюнных желёз;
2. недиагностическая ТАБ образования околоушной железы.

У ранее оперированных больных с гистологически подтверждённым диагнозом ТАБ можно не проводить.

Открытая биопсия

1. недиагностическая ТАБ и (или) core-биопсия;
2. подозрение на неэпителиальную злокачественную опухоль: резкий рост, вовлечение соседних тканей, очаг вне железы, метастазы;
3. необходимость материала для молекулярно-генетического исследования при неоперабельной опухоли.

При обширном поражении обеих долей околоушной железы и подозрении на вовлечение лицевого нерва открытая биопсия показана после двукратного отрицательного цитологического исследования.

3.6 МРТ, КТ и другие исследования

МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием выполняется при подозрении на злокачественную опухоль; строго рекомендуется при подозрении на поражение основания черепа, периневральном росте, интракраниальном распространении, рецидиве или продолженном росте.

КТ лицевого отдела черепа с болюсным контрастированием — при подозрении на поражение верхней или нижней челюсти, основания черепа; КТ органов грудной клетки — всем пациентам со злокачественными опухолями.

1. **остеосцинтиграфия** — при злокачественной опухоли и подозрении на метастазы в кости
2. **ПЭТ всего тела** — только на поздних стадиях; ПЭТ/КТ с ФДГ на начальных стадиях не показана
3. **УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства** — при опухолях с высоким потенциалом злокачественности (аденокарцинома)

3.7 Патолого-анатомическое заключение

Параметры заключения

1. размеры и глубина инвазии опухоли;
2. гистологическое строение и степень дифференцировки;
3. оценка краёв резекции;
4. лимфоваскулярная и периневральная инвазия, pT, pN — только при злокачественной опухоли.

Цитогенетическое исследование проводится при метастатической и неоперабельной опухоли, секреторной карциноме и в сложных диагностических случаях для поиска молекулярных мишеней.

---

4. Лечение

4.1 Хирургическое лечение

Операция является основным методом радикального лечения злокачественных эпителиальных опухолей; её выполняют в специализированном онкологическом центре. Энуклеация опухоли приводит к продолженному росту и методом лечения не считается.

Доброкачественные опухоли удаляют хирургически в объёме частичной резекции, паротидэктомии или субтотальной резекции с выделением и сохранением лицевого нерва; операцию выполняют в специализированном центре онколог, челюстно-лицевой или пластический хирург.

Нейрофизиологический мониторинг лицевого нерва строго показан

1. при опухолях T3–T4;
2. при рецидиве и реоперации;
3. при расширенных резекциях с костями основания черепа;
4. при планировании одномоментной реконструкции лицевого нерва.

Лечение по стадиям

Стадия	Лечение злокачественной опухоли
T1–T2 N0	удаление образования с сохранением ветвей лицевого нерва под мониторингом; при поражённых узлах внутри железы — лимфаденэктомия (IA, IIA, IIB, III); при опухоли высокого потенциала злокачественности — профилактическая лимфаденэктомия на стороне поражения
T1–T2 N+ M0	полное удаление образования с сохранением лицевого нерва под мониторингом; при поражённых узлах внутри железы — лимфаденэктомия (IA, IIA, IIB, III)
T3–T4a N0 M0	полное удаление с обязательным мониторингом и шейной лимфаденэктомией (IA, IIA, IIB, III, IV); при неблагоприятных гистологических признаках рассматривают конкурентную ХЛТ
T3–T4a N+ M0	полное удаление с мониторингом и расширенной шейной лимфаденэктомией; затем послеоперационная ЛТ
T4b	при невозможности радикальной операции — цитогенетическое исследование для таргетной терапии, ДЛТ или их комбинации по решению федерального консилиума
Локорегионарный рецидив	радикальная паротидэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом под мониторингом; при неоперабельности — таргетная терапия или конкурентная ХЛТ по решению консилиума федерального центра
Нерадикальная первичная операция	консилиум федерального центра решает вопрос о повторной ревизионной операции (second-look) или ЛТ

При опухоли высокого потенциала злокачественности, положительных краях или периневральной инвазии рассматривают послеоперационную ДЛТ. Профилактическая лимфодиссекция при низком и промежуточном потенциале злокачественности не рекомендуется, кроме случаев поражённых узлов внутри железы.

Достаточный край резекции

1. низкий и промежуточный потенциал злокачественности: **2 мм и более**;
2. высокий потенциал (аденокистозный рак): **5 мм и более**.

Подозрительные лимфатические узлы биопсируют одномоментно; при пересечении ветвей лицевого нерва выполняют одномоментную пластику — сшивание или аутотрансплантат большого ушного либо икроножного нерва.

4.2 Лучевая терапия

Показания к лучевой терапии

1. низкодифференцированная опухоль;
2. прорастание в основание черепа, мягкие ткани лица, экстрагландулярное распространение;
3. метастазы на шее, инвазия в сосуды или узлы;
4. опухолевые клетки по краю резекции, разрыв опухоли во время операции, большой неудалимый остаток;
5. периневральная инвазия и другие признаки агрессивной опухоли;
6. неоперабельность.

Принципы ЛТ у детей те же, что у взрослых; при топометрии и облучении детей младше 5 лет может потребоваться общая анестезия.

Дозы

1. самостоятельная ЛТ, зона высокого риска (опухоль и поражённые узлы): 66 Гр по 2 Гр;
2. зоны промежуточного и низкого риска: 44–50 Гр по 2 Гр;
3. послеоперационная ЛТ: начало **менее чем через 6 недель** после резекции; положительные края — от 66 Гр, зоны субклинического распространения — от 44–50 Гр.

Лекарственная (молекулярно-направленная) терапия по решению федерального консилиума после молекулярно-генетического исследования

1. секреторная карцинома;
2. неоперабельная опухоль;
3. отдалённые метастазы, когда возможности хирургии и ЛТ исчерпаны.

4.3 Медицинская реабилитация

На всём протяжении лечения оказывают социально-педагогическую помощь ребёнку и социально-психологическую поддержку семье. При парезе ветвей лицевого нерва проводят гимнастику и стимулирующую терапию мимических мышц под контролем логопеда, специалиста по лечебной физкультуре и невролога.

Лечение пареза и паралича мимической мускулатуры по длительности

1. **пересечение ветвей при паротидэктомии** — одномоментная пластика нерва: сшивание, аутотрансплантаты большого ушного или икроножного нерва
2. **паралич до 2 лет** — нейропластика жевательной ветвью тройничного нерва, нисходящей ветвью подъязычного нерва, кросспластика
3. **паралич более 2 лет без нейромышечной активности на ЭМГ** — транспозиция височной мышцы, васкуляризированные мышечные трансплантаты, статическая коррекция, ботулинотерапия

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика и диспансерное наблюдение

Группы риска

1. дети, проживающие в регионах с развитой деревообрабатывающей промышленностью;
2. дети после лучевой терапии на область головы и шеи;
3. дети после терапии радиоактивным йодом по поводу рака щитовидной железы;
4. дети после полихимиотерапии.

Контрольные обследования

1. первый год: **каждые 3 месяца**;
2. до 5 лет: **не реже 1 раза в полгода**;
3. далее: **не реже 1 раза в год**, при злокачественной опухоли — пожизненно.

Объём обследования

1. клиническое обследование;
2. УЗИ желёз и регионарных лимфатических узлов;
3. УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства;
4. МРТ мягких тканей головы с контрастированием;
5. при злокачественной опухоли — КТ лёгких и трёхфазная сцинтиграфия мягких тканей и костей **не реже 1 раза в год**;
6. при парезе лицевого нерва — ЭМГ мимической мускулатуры с двух сторон **через 3, 6 месяцев и 1 год**.

Наблюдение при злокачественной опухоли ведёт детский онколог, при доброкачественной — челюстно-лицевой или детский хирург **до 18 лет**; при парезе лицевого нерва — также невролог, офтальмолог, врач лечебной физкультуры, клинический психолог. После 18 лет пациента переводят во взрослую сеть.

Режим

1. в период лечения вакцинация не проводится, кроме вакцинации против гепатита В;
2. физические нагрузки исключаются на период лечения и **на 1 месяц** после операции;
3. при злокачественной опухоли **в течение 5 лет** не рекомендуются инсоляция и электромиостимуляция околоушно-жевательной области;
4. при сохраняющемся поражении лицевого нерва, нарушениях глотания и жевания возможен перевод на домашнее обучение.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация

1. кровотечение с угрозой жизни;
2. обтурация верхних дыхательных путей с показаниями к трахеостомии;
3. острая потеря сознания, кома;
4. синдром сдавления верхней полой вены;
5. остро возникшее поражение лицевого нерва на стороне опухоли.

Плановая госпитализация

1. уточняющая диагностика;
2. этапы хирургического, лучевого, лекарственного лечения;
3. симптоматическая терапия;
4. хирургическая реабилитация и ботулинотерапия при поражении лицевого нерва.

Специализированная помощь начинается **не позднее 14 календарных дней** с даты патолого-анатомической верификации или установления предварительного диагноза злокачественной опухоли.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Опухоли слюнных желёз у детей»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 27.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	75_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сцинтиграфия костей скелета: во вводной части раздела 2 — всем при первичной диагностике, в разделе 2.4 — только при подозрении на метастатическое поражение костей.
- При парезе лицевого нерва раздел 4 рекомендует стимулирующую терапию мимических мышц, а раздел 7 не рекомендует электромиостимуляцию околоушно-жевательной области при злокачественной опухоли в течение 5 лет.

Клинические рекомендации

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B34.0** — Аденовирусная инфекция неуточненная **B34.2** — Коронавирусная инфекция неуточненная **B34.9** — Вирусная инфекция неуточненная **B97.0** — Аденовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках **B97.4** — Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках **J00** — Острый назофарингит (насморк) **J01** — Острый синусит **J02** — Острый фарингит **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J04** — Острый ларингит и трахеит **J05** — Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит **J06** — Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации **J20** — Острый бронхит **J21** — Острый бронхиолит **J22** — Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.08.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/724_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- При неосложнённой ОРВИ **в первые 10–14 дней** антибактериальная терапия не назначается, в том числе при:
  1. рините;
  2. конъюнктивите;
  3. затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме;
  4. ларингите и крупе;
  5. бронхите.
- При затруднении носового дыхания **более 3–5 дней** и подозрении на бактериальный синусит необходимы рентгенография или компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух для своевременного направления пациента к оториноларингологу. Изменения в пазухах не всегда свидетельствуют о бактериальном воспалении.
- Противовирусные препараты начинают **не позднее 48 часов** от начала заболевания:
  1. первая линия: препараты прямого противовирусного действия;
  2. вторая линия: иммунотропные препараты.
- При выраженной заложенности носа при рините и риносинусите применяют местные деконгестанты, которые облегчают носовое дыхание и восстанавливают проходимость слуховой трубы.
- Препаратом выбора при бактериальном риносинусите является амоксициллин по 500–1000 мг 3 раза в сутки **7–10 дней**.
- Показания к срочной госпитализации:
  1. частота дыхания **более 24 в минуту**;
  2. сатурация **ниже 95%**;
  3. очаговые изменения на рентгенограмме грудной клетки.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) представляют собой группу вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём и поражающих преимущественно верхние, реже нижние дыхательные пути.

Грипп А и В и новая коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2) рассматриваются в отдельных клинических рекомендациях и в данном документе не освещаются.

2.2 Этиология

Наиболее частые возбудители ОРВИ

1. респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) А и В;
2. респираторный энтеровирус;
3. риновирус;
4. аденовирус;
5. метапневмовирус человека;
6. вирусы парагриппа 1–4 типов;
7. сезонные коронавирусы.

Большинство из них РНК-содержащие; их объединяют общие механизмы и пути передачи, стадии развития заболевания и клинические проявления.

2.3 Возбудители и ведущие клинические синдромы

Возбудитель	Основные синдромы
Вирусы парагриппа	Ларингит, ринофарингит, ложный круп
Респираторно-синцитиальный вирус	Бронхит, бронхиолит
Аденовирусы	Фарингит, тонзиллит, бронхит
Риновирусы	Ринит, фарингит
Коронавирусы человека	Ринофарингит, бронхит
Коронавирус ТОРС (тяжёлого острого респираторного синдрома)	Бронхит, бронхиолит, респираторный дистресс-синдром

2.4 Классификация

По типу течения

1. типичная (манифестная);
2. атипичная (бессимптомная, стёртая).

По тяжести

1. лёгкая;
2. средняя;
3. тяжёлая;
4. очень тяжёлая.

По характеру течения

1. неосложнённая;
2. осложнённая: со специфическими осложнениями, с осложнениями, обусловленными вторичной микрофлорой, или с обострением хронических заболеваний.

По длительности

1. острая: **5–10 дней**;
2. подострая: **11–30 дней**;
3. затяжная: **более 30 дней**.

2.5 Критерии степени тяжести

Форма	Признаки
Лёгкая	Температура тела 37–37,5 °C или нормальная, умеренно выраженные катаральные явления, продолжительность заболевания 4–6 дней
Среднетяжёлая	Температура тела 38–39 °C, выраженные катаральные явления; при отсутствии осложнений выздоровление наступает через 6–10 дней
Тяжёлая	Температура тела 39–41 °C; на фоне слабо или резко выраженных катаральных симптомов развиваются угрожающие жизни осложнения

2.6 Клиническая картина

Инкубационный период **от 1 до 14 суток**, у наиболее распространённых вирусов **1–5 дней**. Заболевание, как правило, начинается постепенно.

Интоксикация (умеренно выраженная)

1. повышение температуры тела до субфебрильных или фебрильных значений;
2. слабость;
3. головная боль;
4. боли в мышцах и суставах.

Катаральный синдром

1. першение в горле;
2. кашель;
3. насморк;
4. в ряде случаев конъюнктивит.

Возможно увеличение лимфатических узлов, реже печени (при аденовирусной инфекции).

2.7 Синдромы поражения дыхательных путей

Синдром	Признаки
Острый ринит	Воспаление слизистой оболочки полости носа: чихание, выделения из носа (ринорея), нарушение носового дыхания. Стекание слизи по задней стенке глотки вызывает кашель.
Фарингит	Воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки: внезапно возникающие першение и сухость в горле, боль при глотании.
Тонзиллит	Изменения нёбных миндалин как вирусной природы, так и при обострении бактериальной (стрептококковой) инфекции. Характерны интоксикация, гиперемия и отёк миндалин, нёбных дужек, язычка и задней стенки глотки, рыхлые налёты в лакунах.
Ларингит	Воспаление гортани с вовлечением голосовых складок и подскладкового пространства. Первыми симптомами являются сухой «лающий» кашель и осиплость голоса.
Трахеит	Воспаление слизистой оболочки трахеи: саднение и боль за грудиной, сухой надсадный кашель.
Бронхит	Надсадный кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, удлинённый выдох, рассеянные сухие хрипы, в тяжёлых случаях одышка. Кашель сохраняется 2 недели и более (до месяца). На второй неделе мокрота может приобретать желтовато-зеленоватый оттенок вследствие примеси фибрина и присоединения бактериальной флоры.

2.8 Осложнения

Специфические осложнения

1. менингизм;
2. острая дыхательная недостаточность;
3. энцефалопатия;
4. инфекционно-токсический шок;
5. респираторный дистресс-синдром взрослых;
6. острая сердечно-сосудистая недостаточность;
7. миокардит;
8. тромбоэмболия.

Осложнения, обусловленные вторичной бактериальной микрофлорой

1. острый синусит;
2. острый отит;
3. острый бронхит;
4. обострение хронических бронхолёгочных заболеваний;
5. пневмония.

2.9 Жалобы и анамнез

У всех пациентов уточняют

1. недомогание, утомляемость, слабость, снижение аппетита;
2. повышение температуры тела;
3. головную боль;
4. боль в горле;
5. затруднение носового дыхания, насморк;
6. осиплость;
7. сухой или влажный кашель;
8. увеличение лимфатических узлов;
9. боль в животе, рвоту;
10. одышку, затруднённый вдох;
11. судороги, потерю сознания.

Уточняются длительность заболевания, а также наличие причин, препятствующих незамедлительному началу лечения или требующих его коррекции в связи с сопутствующими заболеваниями.

К таким причинам относятся непереносимость лекарственных препаратов, неадекватное психоэмоциональное состояние, угрожающее жизни острое состояние или обострение хронического заболевания, требующее участия профильного специалиста, а также отказ от лечения.

Эпидемиологический анамнез

1. контакт с больным ОРВИ в пределах инкубационного периода;
2. сезонный подъём заболеваемости;
3. вспышки в организованных коллективах;
4. вакцинация против гриппа.

Факторы риска тяжёлого и осложнённого течения

1. хронические заболевания лёгких и сердца;
2. нарушения обмена веществ;
3. хроническая болезнь почек;
4. заболевания печени;
5. неврологические состояния;
6. гемоглобинопатии;
7. иммунодефициты (ВИЧ-инфекция, приём иммуносупрессоров);
8. злокачественные новообразования;
9. возраст **старше 65 лет**;
10. беременность.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании

1. жалоб и анамнеза;
2. физикального обследования;
3. лабораторных и инструментальных исследований.

Цель диагностики: определить

1. нозологическую и клиническую форму;
2. степень тяжести;
3. наличие осложнений;
4. показания к лечению.

3.1 Осмотр кожи, слизистых оболочек, носа и ротоглотки

Диагностические признаки при осмотре

1. кожные покровы и видимые слизистые оболочки: гиперемия, бледность, цианоз, влажность, отёчность;
2. инъекция сосудов склер, конъюнктивит;
3. носовое дыхание и признаки ринита;
4. ротоглотка: гиперемия нёбных дужек и задней стенки глотки, состояние миндалин, рыхлость и зернистость задней стенки глотки, слизистый налёт, увеличение лимфоидных фолликулов.

Катаральные симптомы необходимо выявлять уже на первом этапе обследования, однако они встречаются и при некоторых бактериальных инфекциях, в частности при стрептококковом или менингококковом назофарингите.

3.2 Осмотр и пальпация лимфатических узлов

Показания

1. все пациенты: осмотр и пальпация лимфатических узлов головы и шеи с оценкой размеров и болезненности.

3.3 Обследование лёгких

Показания

1. все пациенты: пальпация, перкуссия и аускультация лёгких.

Диагностические признаки

1. частота дыхания;
2. характер дыхательных шумов;
3. хрипы;
4. крепитация (появляется при пневмонии).

3.4 Обследование сердечно-сосудистой системы

Показания

1. пациенты с ОРВИ: частота пульса, артериальное давление, аускультация сердца.

Цель: оценка степени тяжести, выявление тахикардии, шумов, осложнений и сопутствующих заболеваний.

3.5 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Показания

1. все пациенты: оценка тяжести, своевременное выявление осложнений, исключение бактериальных осложнений.

Для вирусной инфекции характерны лейкопения или нормальное количество лейкоцитов, лимфоцитоз и моноцитоз.

3.6 Общий анализ мочи

Показания

1. все пациенты: выявление нарушения функции почек, декомпенсации сопутствующих заболеваний, исключение инфекции мочевыводящих путей и нефропатии.

При неосложнённой ОРВИ изменения отсутствуют; при выраженной лихорадке возможны преходящее повышение относительной плотности мочи, незначительные лейкоцитурия, протеинурия и цилиндрурия.

3.7 Биохимический анализ крови

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение: активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), амилазы, уровень мочевины и электролитов.

3.8 Экспресс-тест на антигены вирусов

Показания

1. пациенты с симптомами респираторной инфекции, обратившиеся **не позднее 2 суток** от начала симптомов.

Цель: своевременное назначение противовирусной терапии.

Иммунохроматографический тест: антигены вирусов гриппа A и B, РСВ, аденовируса и SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки.

3.9 Методы амплификации нуклеиновых кислот

Мазки из носоглотки и ротоглотки исследуют методами амплификации нуклеиновых кислот (полимеразная цепная реакция (ПЦР), петлевая изотермическая амплификация (LAMP) и другие) на вирусы ОРВИ, гриппа и SARS-CoV-2.

Показания

1. пациенты с симптомами респираторной инфекции.

Цель: идентификация возбудителя.

Это наиболее эффективный метод: нуклеиновые кислоты вирусов выявляются в среднем **до 7 дней**, максимально **до 2 недель** от начала заболевания при сохранении признаков поражения верхних дыхательных путей.

Результат готов **через 4–6 часов**.

Обследование пациентов с тонзиллитом и пневмонией осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями по данным заболеваниям.

3.10 Пульсоксиметрия

Измерение сатурации крови кислородом (SpO2).

Показания

1. пациенты с ОРВИ.

Цель: ранняя диагностика дыхательной недостаточности, выявление пациентов с гипоксемией, нуждающихся в респираторной поддержке.

3.11 Рентгенография органов грудной клетки или КТ лёгких

Показания

1. бронхит продолжительностью **более 3–5 дней**;
2. физикальные признаки поражения лёгких.

Цель: исключение или подтверждение пневмонии.

3.12 Рентгенография или КТ околоносовых пазух

Показания

1. затруднение носового дыхания **более 3–5 дней** и подозрение на синусит вследствие присоединения бактериальной флоры.

Цель: своевременное направление пациента к оториноларингологу.

Данное осложнение встречается в 0,5–2% случаев ОРВИ у взрослых. Изменения в околоносовых пазухах не всегда свидетельствуют об их бактериальном поражении.

3.13 Электрокардиография

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение, особенно у пациентов пожилого возраста: оценка функции сердца и выявление нарушений ритма на фоне интоксикации.

3.14 Консультации специалистов

Консультации смежных специалистов при подозрении на осложнения

1. оториноларинголог: синусит, отит;
2. невролог: энцефалопатия;
3. пульмонолог: признаки пневмонии;
4. гематолог: выраженные изменения в анализе крови, геморрагический синдром;
5. кардиолог: миокардит, острая сердечно-сосудистая недостаточность;
6. акушер-гинеколог: беременность.

Консультация анестезиолога-реаниматолога для перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ):

1. быстро нарастающая острая дыхательная недостаточность: частота дыхания **более 25 в минуту**, SpO2 **ниже 92%**;
2. другая органная недостаточность: **2 балла и более** по шкале SOFA.

3.15 Алгоритм ведения на амбулаторном этапе

1. При катаральных явлениях выполняют общий анализ крови и обследование лёгких.
2. Если изменений в лёгких нет, лечение амбулаторное; при сохранении лихорадки на фоне лечения общий анализ крови повторяют, а при наличии изменений направляют к инфекционисту.
3. Если в лёгких есть изменения, выполняют рентгенографию; при отсутствии признаков пневмонии — рентгенографию околоносовых пазух.
4. При изменениях в пазухах пациента направляют к оториноларингологу.

3.16 Дифференциальная диагностика

Необходимо дифференцировать респираторные вирусные заболевания с острыми респираторными заболеваниями бактериальной этиологии, в том числе вирусную пневмонию с бактериальной.

3.17 Дифференциально-диагностические признаки основных ОРВИ

Возбудитель	Начало и течение заболевания	Лихорадка и интоксикация	Поражение носа и глотки	Кашель и другие проявления
Парагрипп	Инкубационный период 2–7 дней, чаще 3–4; начало постепенное, течение подострое	37–38 °С, может сохраняться длительно; интоксикация слабо или умеренно выражена, 1–3 дня	Катаральные явления с первого дня, осиплость голоса; заложенность носа; слабая или умеренная гиперемия слизистой оболочки зева, мягкого нёба и задней стенки глотки	Сухой «лающий» кашель, в ряде случаев до 12–21 дня; ведущими синдромами являются ларингит и ложный круп

Возбудитель	Начало и течение заболевания	Лихорадка и интоксикация	Поражение носа и глотки	Кашель и другие проявления
РС-инфекция	Инкубационный период 3–6 дней; начало постепенное, течение подострое, в ряде случаев затяжное	Субфебрильная, в ряде случаев нормальная; интоксикация умеренная или слабая, 2–7 дней	Катаральные явления нарастают постепенно; заложенность носа, необильные серозные выделения; слабая гиперемия слизистых оболочек	Сухой приступообразный кашель до 3 недель с болью за грудиной; бронхит, бронхиолит, возможен бронхоспазм
Аденовирусная инфекция	Инкубационный период 4–14 дней; начало постепенное, течение затяжное, волнообразное	Фебрильная или субфебрильная; интоксикация умеренная, 8–10 дней	Резко выраженные катаральные явления; обильные слизисто-серозные выделения, резкое затруднение носового дыхания; умеренная гиперемия и гиперплазия фолликулов задней стенки глотки	Влажный кашель; ринофаринго-конъюнктивит, тонзиллит, конъюнктивит, кератит; возможны полиаденит, гепатоспленомегалия, экзантема, диарея

4. Лечение

Целями лечения являются подавление репликации вируса в ранние сроки, предотвращение прогрессирования заболевания, достижение полного выздоровления и профилактика осложнений.

Хирургическое лечение не проводится.

4.1 Базисная терапия

Всем пациентам независимо от степени тяжести:

1. постельный режим;
2. диета: легкоусвояемые продукты, богатые витаминами;
3. обильное питьё;
4. исключение алкоголя в любом виде.

Дезинтоксикационная терапия всем пациентам без поражения лёгких:

1. лёгкое и среднетяжёлое течение, амбулаторно: приём **2–3 литров** жидкости в сутки;
2. среднетяжёлое течение, стационар: пероральная регидратация и (или) инфузия **800–2000 мл** растворов, влияющих на водно-электролитный баланс;
3. осложнённое и тяжёлое течение: внутривенная дезинтоксикационная терапия с коррекцией электролитных нарушений.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении и при поражении лёгких для купирования интоксикации применяют меглюмина натрия сукцинат внутривенно капельно со скоростью 1–4,5 мл/мин, в среднем 10 мл/кг в сутки, курсом до 11 дней.

4.2 Противовирусная терапия

Противовирусные препараты начинают **не позднее 48 часов** от начала заболевания:

1. первая линия: препараты прямого противовирусного действия;
2. вторая линия: иммунотропные препараты с опосредованным действием: интерфероны, другие иммуностимуляторы и общетонизирующие средства.

Выбор препарата определяется возбудителем. Раннее назначение противовирусной терапии предупреждает тяжёлое течение и развитие осложнений; целесообразность назначения противовирусного препарата определяется врачом индивидуально для каждого пациента.

Препарат	Доза	Противопоказания (кроме гиперчувствительности)
Риамиловир (первая линия)	Внутрь 250 мг 3 раза в день в течение 5 дней; лечение следует начать не позднее 2-го дня болезни	в рекомендации не указаны
Умифеновир (первая линия)	200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 суток	I триместр беременности
Энисамия йодид (первая линия)	Внутрь 500 мг 3 раза в сутки в течение 5–7 дней	беременность и грудное вскармливание, тяжёлые органические поражения печени и почек, аллергические реакции в анамнезе, дефицит лактазы и сахаразы/изомальтазы, непереносимость лактозы и фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция
Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (вторая линия)	90 мг 1 раз в день в течение 5–7 дней, приём желательно начать в первые 2 суток	беременность, период лактации, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция
Меглюмина акридонацетат (вторая линия)	По 4 таблетки однократно на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки (всего 20 таблеток)	беременность, период лактации
Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат (вторая линия)	В первый день 200 мг 3 раза, в последующие 7 дней по 200 мг 1 раз в сутки (на курс 2000 мг)	беременность, период лактации, возраст до 12 лет, наследственная непереносимость лактозы, недостаточность лактазы, нарушение всасывания глюкозы и галактозы

Препарат	Доза	Противопоказания (кроме гиперчувствительности)
Азоксимера бромид (вторая линия)	Таблетки: по 1 таблетке под язык 2 раза в день в течение 7 дней. Раствор: парентерально 6 мг в сутки в течение 3 дней, затем через день, всего 10 инъекций, или интраназально либо сублингвально по 6 мг в сутки в 2–3 приёма. Суппозитории: 12 мг 1 раз в сутки, 10 суппозиториев	беременность, грудное вскармливание
Тилорон (вторая линия)	125 мг в сутки в первые 2 дня, затем по 125 мг через 48 часов, на курс 750 мг (6 таблеток)	беременность, период лактации, возраст до 18 лет
Антитела к гамма-интерферону, гистамину и CD4 (Эргоферон)	В 1-й день 8 таблеток: по 1 таблетке каждые 30 минут в течение первых 2 часов, затем ещё 3 раза; со 2-го дня по 1 таблетке 3 раза в день до выздоровления	врождённая галактоземия, мальабсорбция глюкозы или галактозы, врождённая лактазная недостаточность; у беременных и в период лактации эффективность и безопасность не изучались
Антитела к гамма-интерферону, CD4 и молекулам MHC (Рафамин)	В 1-й день по той же схеме, затем по 1 таблетке 3 раза в день; общая продолжительность 5 дней, с 18 лет	врождённая галактоземия, мальабсорбция глюкозы или галактозы, врождённая лактазная недостаточность; у беременных и в период лактации эффективность и безопасность не изучались

Беременность и лактация

1. умифеновир противопоказан в I триместре беременности;
2. при беременности и в период лактации противопоказаны энисамия йодид, имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, меглюмина акридонацетат, оксиэтиламмония метилфеноксиацетат, азоксимера бромид, тилорон;
3. для препаратов антител к гамма-интерферону (Эргоферон, Рафамин) эффективность и безопасность у беременных и в период лактации не изучались.

Возможно применение интраназальных интерферонов, которые обладают опосредованным действием и используются в комплексной терапии с первых признаков заболевания. В рекомендации отмечено, что они не входят в перечень препаратов международных клинических рекомендаций.

Интерферон альфа-2b

1. по 3 капли (дозы) в каждый носовой ход 5–6 раз в день: 3000 МЕ на приём, 15 000–18 000 МЕ в сутки;
2. курс 5 дней.

Интерферон гамма человеческий рекомбинантный

1. по 2 капли в каждый носовой ход после туалета носа 5 раз в день;
2. курс 5–7 дней.

Лизаты бактерий назначают в составе комплексного лечения с иммуностимулирующей целью при неосложнённой ОРВИ, а также пациентам с частыми, тяжёлыми или затяжными респираторными инфекциями в анамнезе.

С первых дней заболевания по 1 капсуле утром натощак за 30 минут до еды до исчезновения симптомов, **не менее 10 дней**.

4.3 Жаропонижающая терапия

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) назначают при температуре тела **выше 38 °C** и болях в мышцах и суставах.

Препараты выбора

1. парацетамол по 500–1000 мг каждые 4–6 часов при необходимости, **не более 4000 мг в сутки**;
2. ибупрофен по 400 мг 3 раза в сутки, **не более 1200 мг в сутки**;
3. возможны комбинации ибупрофена с парацетамолом и парацетамола с фенилэфрином и фенирамином.

НПВП применяются только для снижения температуры тела и обезболивания; длительные курсы нецелесообразны, поскольку могут затруднить оценку эффективности лечения.

4.4 Местная терапия ринита и риносинусита

Физиологический раствор натрия хлорида вводится в полость носа 2–3 раза в день; он разжижает секрет, способствует удалению слизи и восстанавливает функцию мерцательного эпителия.

При выраженном затруднении носового дыхания в комплексном лечении ринита и риносинусита применяются местные деконгестанты для уменьшения заложенности носа и восстановления проходимости слуховой трубы.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Ксилометазолин	По 1–2 капли (1 впрыскивание) 3 раза в день
Нафазолин	По 1–3 капли 0,05–0,1% раствора 3–4 раза в сутки
Ипратропия бромид + ксилометазолин	Фиксированная комбинация, применяется при обильной ринорее; доза в рекомендации не указана
Оксиметазолин	0,05% раствор, по 1–2 капли или 1–2 впрыскивания 2 раза в сутки

Показания

1. назофарингит и неосложнённый риносинусит с заложенностью носа, ринореей и стеканием слизи по задней стенке глотки; назначают с первого дня.

Состав комбинированного растительного препарата

1. корень горечавки;
2. цветки первоцвета;
3. трава щавеля;
4. цветки бузины;
5. трава вербены.

Препарат улучшает функцию мукоцилиарного аппарата и отток экссудата, ускоряет выздоровление, способствует профилактике осложнений.

1. сухой экстракт: по 160 мг (1 таблетка) 3 раза в день;
2. измельчённое растительное сырьё: по 156 мг (2 таблетки) 3 раза в день;
3. капли: по 50 капель 3 раза в день;
4. курс 7–14 дней.

Беременным при насморке, назофарингите и остром риносинусите препарат может быть назначен после консультации врача в форме таблеток, а при невозможности их приёма в форме капель.

4.5 Местная терапия фарингита и тонзиллита

Для уменьшения воспаления и болевого синдрома и профилактики вторичной инфекции слизистой оболочки ротоглотки назначаются препараты для лечения заболеваний горла и антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций, таблеток и пастилок для рассасывания.

Препараты для местной терапии

1. грамицидин С с цетилпиридинием (в том числе с оксибупрокаином);
2. бензидамин или флурбипрофен с цетилпиридинием;
3. гексэтидин;
4. лизоцим с пиридоксином;
5. хлоргексидин;
6. бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний;
7. биклотимол;
8. препараты йода.

Показания: фарингит и тонзиллит

1. боль в горле в покое и при глотании;
2. гиперемия слизистой оболочки глотки и миндалин;
3. увеличение миндалин.

Состав растительного антисептика

1. корень алтея, цветки ромашки, трава тысячелистника;
2. кора дуба, листья грецкого ореха;
3. трава хвоща, трава одуванчика.

Препарат уменьшает боль и воспаление, способствует профилактике осложнений и повторных эпизодов ОРВИ.

Таблетки — по 2 таблетки (96 мг) 5–6 раз в день, капли — по 25 капель 5–6 раз в день до купирования боли в горле, затем ещё в течение недели 3 раза в день. Препарат может назначаться беременным и пациентам с соматическими заболеваниями после консультации врача.

4.6 Противокашлевая и мукоактивная терапия

При сухом непродуктивном надсадном кашле, значительно ухудшающем качество жизни (болевой синдром, нарушение сна), назначают противокашлевые средства:

1. бутамират;
2. леводропропизин;
3. антитела к брадикинину, морфину и гистамину;
4. декстрометорфан в составе комбинированных препаратов.

Бутамират в форме сиропа — по 15 мл 4 раза в сутки. Леводропропизин — по 60 мг 1–3 раза в сутки с интервалом не менее 6 часов. Антитела к брадикинину, морфину и гистамину — по 1–2 таблетки или 5–10 мл раствора 3 раза в сутки, в первые 3 дня до 4–6 раз.

При остром вирусном бронхите и трахеите с влажным кашлем и бронхообструкцией назначаются муколитические и отхаркивающие средства, но не в комбинации с противокашлевыми. Муколитические препараты, в том числе растительные, применяются только при продуктивном кашле.

Муколитические и отхаркивающие средства

1. ацетилцистеин: 600 мг в сутки до 5–7 дней;
2. бромгексин: внутрь по 8 мг (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки;
3. амброксол: 90 мг в сутки, в форме капсул пролонгированного действия 75 мг в сутки, до 14 дней;
4. амброксол + натрия глицирризинат + тимьяна ползучего травы экстракт: внутрь 40 мл в сутки (по 10 мл 4 раза);
5. амброксол + натрия гидрокарбонат + натрия глицирризинат + термопсиса ланцетного травы экстракт: по 1 таблетке 3 раза в сутки;
6. плюща обыкновенного листьев экстракт + тимьяна травы экстракт, сироп: по 5,4 мл 3 раза в сутки после еды, 10–14 дней;
7. первоцвета корней экстракт + тимьяна травы экстракт: по 1 таблетке 3 раза в день перед едой, 10–14 дней.

Одновременное назначение отхаркивающих и противокашлевых средств не рекомендуется, поскольку подавление кашлевого рефлекса может привести к застою мокроты.

При остром вирусном бронхите с влажным кашлем для облегчения отхождения вязкой мокроты рекомендуются небулайзерные ингаляции гипертонического раствора натрия хлорида (3% или 7%) с гиалуронатом натрия по 5 мл 2 раза в день.

При бронхообструктивном синдроме, обусловленном бронхоспазмом, применяют комбинацию ипратропия бромида с фенотеролом: в форме дозированного аэрозольного ингалятора по 1–2 вдоха до 3–4 раз в сутки или через небулайзер по 1–2 мл до 3–4 раз в сутки.

При продуктивном кашле, особенно с признаками бронхиальной обструкции, взрослым может назначаться амброксол с гвайфенезином и левосальбутамолом по 10 мл 3 раза в день в течение 2 недель.

4.7 Антибактериальная терапия

При неосложнённой ОРВИ **в первые 10–14 дней** антибактериальная терапия не назначается, в том числе при:

1. рините;
2. конъюнктивите;
3. затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме;
4. ларингите и крупе;
5. бронхите и бронхообструктивном синдроме.

Показания к антибактериальной терапии:

1. вероятная сопутствующая бактериальная инфекция;
2. неэффективность патогенетической, симптоматической и противовирусной терапии;
3. бактериальные осложнения среднетяжёлой и тяжёлой ОРВИ: бронхит, пневмония и другие.

4.8 Антибактериальная терапия бактериального риносинусита

Препарат	Доза
Амоксициллин	Внутрь 500–1000 мг 3 раза в сутки в течение 7–10 дней
Амоксициллин и клавулановая кислота	Внутрь 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки в течение 7–10 дней

Препарат	Доза
Азитромицин	Внутрь 500 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней
Кларитромицин	500 мг 1 раз в сутки в течение 7–10 дней (кратность приведена по тексту рекомендации)
Левофлоксацин	Внутрь 500 мг до 5–7 дней; применяется при устойчивой микрофлоре, неэффективности других антибиотиков, экзантеме или лекарственной аллергии на другие антибиотики

> В рекомендации имеется расхождение в сроках. Антибактериальная терапия не рекомендуется до 10–14 дней даже при затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме, однако рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит рекомендуется выполнять уже при заложенности носа более 3–5 дней, а в разделе об организации медицинской помощи сохранение высокой температуры тела более 3 дней названо клиническим признаком вторичной бактериальной инфекции.

Лечение пневмонии в данных рекомендациях не рассматривается и проводится в соответствии с клиническими рекомендациями по внебольничной пневмонии у взрослых.

4.9 Терапия тяжёлого течения

При тяжёлой ОРВИ с инфекционно-токсическим шоком или отёком головного мозга применяют системные глюкокортикоиды; лечение таких пациентов осуществляется в ОРИТ в соответствии с рекомендациями по неотложным состояниям.

При поражении лёгких с дыхательной недостаточностью (SpO2 **ниже 92%**) необходима оксигенотерапия через носовые канюли, лицевую маску или аппарат высокопоточной оксигенации. Начальная скорость потока **5–7 л/мин**, при необходимости до 10 л/мин для поддержания SpO2 выше 90%.

4.10 Дополнительная терапия

Для защиты слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне приёма лекарственных препаратов, в том числе НПВП, назначается омепразол 20 мг 1 раз в день.

Пробиотики рекомендованы пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, функциональными расстройствами пищеварения, заболеваниями кожи, а также при приёме антибиотиков более 7 дней в настоящее время или в предшествующие 1–2 месяца. Пробиотики применяются в ранние сроки заболевания в сочетании с другими препаратами.

Пробиотики

1. бифидобактерии бифидум однокомпонентный сорбированный: по 2–3 капсулы или 2–3 пакетика 2 раза в день, 7–10 дней;
2. бифидобактерии бифидум + лактобактерии плантарум: по 1 капсуле или пакету 3 раза в сутки, 5–10 дней;
3. Lactobacillus acidophilus (LA-5) + Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12): 1–3 капсулы в день в зависимости от тяжести симптомов;
4. бифидобактерии лонгум + энтерококкус фециум: 2–3 капсулы в сутки, 10–21 день;
5. сахаромицеты буларди: по 1–2 капсулы 2 раза в день во время применения антибиотика.

4.11 Медицинская реабилитация

Реабилитация начинается в периоде ранней реконвалесценции.

При вирусной и поствирусной астении применяют общетонизирующие препараты, в частности оксиэтиламмония метилфеноксиацетат: в первый день 600 мг, в последующие 7 дней по 200 мг, всего 2000 мг за 8 дней.

Восстановительное лечение проводится комплексно, с участием специалистов разного профиля, последовательно и преемственно на всех этапах, с учётом резервов пациента и при постоянном контроле эффективности. Физическая и умственная нагрузка увеличивается постепенно.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Перед выбором тактики ведения определяется характер течения заболевания (неосложнённое или осложнённое).

Лечение лёгкой и среднетяжёлой ОРВИ амбулаторное. При неэффективности лечения или невозможности его проведения в домашних условиях решается вопрос о госпитализации.

Госпитализации подлежат пациенты:

1. с тяжёлым, среднетяжёлым и осложнённым течением;
2. из групп риска;
3. по эпидемическим показаниям, в том числе с лёгким течением при проживании в общежитии или в неблагоприятных условиях.

> В рекомендации имеется противоречие в отношении среднетяжёлого течения: одна рекомендация раздела 6 предусматривает амбулаторное лечение таких пациентов, следующая предусматривает их госпитализацию.

Показания к срочной госпитализации:

1. частота дыхания **более 24 в минуту**;
2. SpO2 **ниже 95%**;
3. очаговые изменения на рентгенограмме грудной клетки.

Показания к переводу в ОРИТ:

1. быстро нарастающая острая дыхательная недостаточность: частота дыхания **более 30 в минуту**, SpO2 **ниже 90%**, систолическое артериальное давление **ниже 90 мм рт. ст.**;
2. другая органная недостаточность, например острая почечная недостаточность.

> Пороговые значения для перевода в ОРИТ в разных разделах рекомендации различаются: в разделе 2.5 консультация анестезиолога-реаниматолога показана при частоте дыхания более 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 перевод в ОРИТ показан при частоте дыхания более 30 в минуту и SpO2 ниже 90%.

При прогрессировании заболевания схему ведения срочно пересматривают. Признаки прогрессирования:

1. гипоксия и сердечно-лёгочная недостаточность: одышка, цианоз, кровянистая мокрота, боль в грудной клетке, артериальная гипотензия, снижение сатурации;
2. поражение нервной системы: нарушение сознания, сонливость, судороги, выраженная слабость, параличи;
3. вторичная бактериальная инфекция, в том числе сохранение высокой температуры тела и других симптомов **более 3 дней**;
4. тяжёлая дегидратация.

Выписка возможна при:

1. стойком улучшении состояния;
2. нормальной температуре тела;
3. регрессе респираторно-катарального синдрома;
4. нормальных показателях общего анализа крови.

Группы риска тяжёлого течения

1. беременные и родильницы;
2. хронические заболевания лёгких, сердца и сосудов;
3. сахарный диабет, ожирение 2–3 степени;
4. хроническая болезнь почек;
5. заболевания печени;
6. некоторые неврологические состояния;
7. гемоглобинопатии;
8. иммунодефициты;
9. злокачественные новообразования;
10. возраст **65 лет и старше**.

5.2 Диспансерное наблюдение

При развитии осложнений наблюдение осуществляет терапевт, а после аденовирусной инфекции — инфекционист кабинета инфекционных заболеваний поликлиники.

В течение месяца после выписки вакцинация не проводится, за исключением введения анатоксина столбнячного и вакцины против бешенства по показаниям.

После перенесённого заболевания рекомендуется ограничение инсоляции на срок от 2 недель до месяца в зависимости от тяжести течения.

5.3 Профилактика

Вакцины против ОРВИ отсутствуют.

1. среди контактных лиц выявляют заболевших;
2. больного изолируют на дому, при необходимости в отдельном боксе стационара, до клинического выздоровления, в среднем **на 1–2 недели**; затем он может приступить к работе;
3. карантин для контактных лиц не вводится.

При работе с больными ОРВИ необходимо использование маски со сменой каждые 3–4 часа.

Необходимы обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей, влажная уборка и проветривание помещений.

После контакта с больным ОРВИ рекомендуется химиопрофилактика. Экстренная профилактика в очаге продолжается 2 дня при прекращении контакта и 5–7 дней при его сохранении. Плановая сезонная профилактика проводится перед эпидемическим подъёмом заболеваемости лицам с высоким риском заражения и неблагоприятного исхода.

Препарат	Доза для профилактики
Умифеновир	После контакта — 200 мг в сутки в течение 10–14 дней; сезонная профилактика — 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель
Оксодигидроакридинилацетат натрия	250 мг (1 ампула) или 4–6 мг/кг на введение; при длительном применении — с интервалом 3–7 суток

Препарат	Доза для профилактики
Интерферон альфа-2b	По 3 капли в каждый носовой ход 2 раза в сутки в течение 5–7 дней; при однократном контакте достаточно однократного закапывания
Интерферон гамма человеческий рекомбинантный	По 2–3 капли в каждый носовой ход за 30 минут до завтрака в течение 10 дней
Меглюмина акридонацетат	Не позднее 3 дней после контакта — 600 мг (4 таблетки) в сутки на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки
Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат	200 мг в сутки после еды в течение 14 дней
Азоксимера бромид	По 1 таблетке в день в течение 10 дней, или 6 мг в сутки интраназально или сублингвально, или суппозитории 12 мг 1 раз в сутки, 10 суппозиториев
Тилорон	125 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель
Антитела к гамма-интерферону (Анаферон)	По 1 таблетке в день в течение 1–3 месяцев в период подъёма заболеваемости

Лизаты бактерий для профилактики повторных респираторных инфекций и вторичной бактериальной инфекции, независимо от сезона:

1. лица, проживающие в неблагоприятных экологических условиях;
2. хронический бронхит;
3. хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ);
4. бронхиальная астма;
5. хронический риносинусит;
6. хронический тонзиллит.

Три курса по 10 дней с интервалами по 20 дней.

Взрослым перед эпидемическим сезоном и во время него длительно, от 6 месяцев до года, рекомендуется #колекальциферол (пометка off-label, в КР — знак #, означает применение вне инструкции по медицинскому применению).

1. без ожирения: 2000 МЕ в сутки или 10 000 МЕ в неделю;
2. при ожирении: 3000–6000 МЕ в сутки.

Пациенту разъясняется необходимость срочного обращения к врачу при высокой температуре тела, одышке, стойкой головной боли, повторной рвоте, не приносящей облегчения, и резком снижении артериального давления.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 04.08.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее августа 2028 года
Код в рубрикаторе	724_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российское научное медицинское общество терапевтов; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 6 одна рекомендация предусматривает амбулаторное лечение среднетяжёлой ОРВИ, а следующая предусматривает госпитализацию.
- Пороговые значения для перевода в реанимацию расходятся: в разделе 2.5 частота дыхания более 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 частота дыхания более 30 в минуту и SpO2 ниже 90%.
- Антибактериальная терапия не рекомендуется до 10–14 дней даже при затемнении околоносовых пазух, однако рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит рекомендуется выполнять уже при заложенности носа более 3–5 дней, а сохранение температуры более 3 дней в разделе 6 расценивается как признак вторичной бактериальной инфекции.
- В алгоритме (приложение Б) рентгенография околоносовых пазух предусмотрена только при изменениях в лёгких без признаков пневмонии, тогда как в разделе 2.4 она назначается в зависимости от длительности затруднения носового дыхания.
- Кларитромицин при риносинусите указан в дозе 500 мг 1 раз в сутки; для оксиметазолина в одной фразе смешаны капли и впрыскивания; доза бромгексина записана неразборчиво («по 8 мг 3 (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки»).

Клинические рекомендации

Острый ларингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J04.0** — Острый ларингит **J04.2** — Острый ларинготрахеит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 01.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/309_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Ларингоскопия показана всем пациентам. **С 12 лет** гортань осматривают гортанным зеркалом; если у ребёнка младшего возраста такой осмотр невозможен, прибегают к видеофиброринофаринголарингоскопии.
- При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции и длительности симптомов **менее 10 дней** антибактериальная терапия не назначается.
- При сохранении симптомов **в течение 10 дней** и при осложнённом течении показана системная антибактериальная терапия; препаратом выбора является амоксициллин.
- При дисфонии показан полный голосовой покой **на 1–2 суток** с последующим ограничением голосовой нагрузки; из рациона исключаются острая, солёная, горячая и холодная пища, необходим отказ от алкоголя и курения.
- Показания к срочной госпитализации в стационар с отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи:
  1. флегмонозный ларингит;
  2. абсцедирующий ларингит;
  3. инфильтративный ларингит;
  4. хондроперихондрит гортани.
- Ларингит без стеноза гортани на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не требует госпитализации. При дыхательной недостаточности **выше I степени** необходима экстренная госпитализация.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острый ларингит (ОЛ): острое воспаление слизистой оболочки гортани длительностью **до 3 недель**. При длительности **более 3 недель** необходимо исключить аутоиммунную природу.

Абсцедирующий, или флегмонозный, ларингит: форма острого ларингита с образованием абсцесса, чаще на язычной поверхности надгортанника или на черпалонадгортанных складках.

Проявления абсцедирующего ларингита

1. резкая боль при глотании и разговоре с иррадиацией в ухо;
2. повышение температуры тела;
3. плотный инфильтрат в тканях гортани.

Острый хондроперихондрит гортани: острое воспаление хрящей гортани с вовлечением надхрящницы и окружающих тканей.

Острый подскладочный ларингит (круп) характеризуется воспалением в подголосовом пространстве с отёком слизистой оболочки под голосовыми складками, затруднением дыхания и одышкой. Заболевание встречается у детей в возрасте **от 6 месяцев до 6 лет**.

2.2 Этиология

Как правило, острый ларингит является проявлением острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ):

1. грипп;
2. парагрипп;
3. аденовирусная инфекция.

Воспаление затрагивает также слизистую оболочку полости носа и глотки, в ряде случаев бронхи и лёгкие; может быть продолжением катарального воспаления полости носа или глотки.

Основными возбудителями бактериального ларингита являются S. pneumoniae (20–43%) и H. influenzae (22–35%); достаточно часто высеваются Moraxella catarrhalis (2–10%), различные стрептококки и стафилококки, значительно реже Neisseria, Corynebacterium и другие микроорганизмы.

Неинфекционные причины

1. наружная и внутренняя травма шеи и гортани, в том числе ингаляционная;
2. инородное тело;
3. аллергия;
4. гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
5. повышенная голосовая нагрузка.

Предрасполагающие факторы

1. хронические заболевания бронхов и лёгких, полости носа и околоносовых пазух;
2. сахарный диабет, гипотиреоз;
3. заболевания желудочно-кишечного тракта;
4. хроническая почечная недостаточность;
5. нарушение разделительной функции гортани;
6. употребление алкоголя, курение;
7. лучевая терапия в анамнезе.

2.3 Классификация

По форме

1. катаральный;
2. отёчный;
3. флегмонозный (инфильтративно-гнойный, в том числе инфильтративный и абсцедирующий);
4. острый подскладочный.

По этиологии

1. вирусный;
2. бактериальный;
3. грибковый;
4. специфический.

2.4 Клиническая картина

Основные симптомы

1. нарушение голоса, от лёгкой дисфонии до афонии;
2. острая боль в горле;
3. кашель;
4. возможны затруднение дыхания и ухудшение самочувствия.

Заболевание начинается внезапно, на фоне удовлетворительного состояния или небольшого недомогания. При катаральном ларингите температура тела нормальная или субфебрильная; фебрильная лихорадка, как правило, свидетельствует о вовлечении нижних дыхательных путей или о переходе катарального процесса во флегмонозный.

Инфильтративная и абсцедирующая формы

1. выраженная боль в горле;
2. нарушение глотания, в том числе жидкости;
3. повышенное слюноотделение;
4. вынужденное положение головы;
5. выраженная интоксикация;
6. нарастающие признаки стеноза гортани.

Общее состояние тяжёлое. При отсутствии адекватного лечения возможно развитие флегмоны шеи, медиастинита, сепсиса, абсцедирующей пневмонии, стеноза гортани.

Клиническая картина острого стеноза гортани не зависит от его причины и определяется степенью сужения:

1. шумное дыхание с нарушением ритма;
2. западение надключичных ямок и втяжение межрёберных промежутков на вдохе;
3. запрокидывание головы;
4. гортань опускается на вдохе и поднимается на выдохе.

При неполной обструкции возникает стридор. При преобладании отёка дыхание свистящее, при преобладании гиперсекреции хриплое, клокочущее. В терминальной стадии стеноза дыхание становится всё более тихим вследствие уменьшения дыхательного объёма.

При абсцессе надгортанника на фоне острой боли вначале развивается невозможность глотания, а по мере прогрессирования процесса затруднение дыхания. Голосовая щель может закрыться очень быстро, что требует экстренных мероприятий для спасения жизни пациента.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливают на основании анамнеза, жалоб, данных физикального обследования и ларингоскопии.

Жалобы

1. изменение голоса;
2. боль при глотании;
3. кашель;
4. повышение температуры тела.

Признаки тяжёлых форм

1. ухудшение общего состояния;
2. боль при глотании даже жидкости;
3. фебрильная лихорадка;
4. повышенное слюноотделение;
5. нарушение дыхания;
6. болезненность шеи и гортани при пальпации, нарушение подвижности хрящей гортани;
7. вынужденное положение головы и шеи.

3.2 Осмотр и оценка дыхательной недостаточности

Показания

1. подозрение на острый ларингит: осмотр оториноларинголога, врача общей практики (семейного врача) или педиатра.

Оценка дыхательной недостаточности (основной признак: одышка)

1. I степень: одышка при физической нагрузке;
2. II степень: одышка при незначительной нагрузке (неспешная ходьба, умывание, одевание);
3. III степень: одышка в покое.

Стадии стеноза гортани

Стадия	Признаки
Компенсация	Одышка в покое отсутствует, возникает при ходьбе; просвет гортани сужен на треть.
Субкомпенсация	Инспираторная одышка при нагрузке с участием вспомогательной мускулатуры, втяжение межрёберных промежутков, яремной и надключичных ямок, стридор, бледность кожных покровов; артериальное давление нормальное или повышенное; просвет гортани сужен наполовину и более.
Декомпенсация	Дыхание поверхностное, частое, резко выраженный стридор, вынужденное положение сидя, максимальные экскурсии гортани, лицо бледно-синюшное, потливость, акроцианоз, пульс частый, нитевидный, артериальное давление снижено; просвет гортани щелевидный.
Асфиксия	Дыхание прерывистое или отсутствует, голосовая щель резко сужена, сердечная деятельность угнетена, пульс частый, нитевидный, часто не определяется, кожные покровы бледно-серые; потеря сознания, экзофтальм, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, остановка сердца.

При быстром нарастании стеноза состояние пациента тяжелее, поскольку компенсаторные механизмы не успевают развиться. Это учитывается при решении вопроса об экстренном хирургическом вмешательстве.

3.3 Ларингоскопия

Выполняется всем пациентам с острым ларингитом.

1. непрямая ларингоскопия гортанным зеркалом обязательна при осмотре оториноларингологом пациентов **12 лет и старше** в поликлинике и в стационаре;
2. у детей дошкольного и младшего школьного возраста в поликлинике непрямая ларингоскопия часто невозможна из-за эмоциональной лабильности и выраженного глоточного рефлекса, поэтому проводят видеофиброринофаринголарингоскопию.

Ларингоскопия позволяет определить характер процесса, его локализацию, уровень, протяжённость и степень сужения дыхательных путей.

Диагностические признаки острого ларингита

1. гиперемия и отёк слизистой оболочки гортани с усилением сосудистого рисунка;
2. голосовые складки розовые или ярко-красные, утолщены;
3. голосовая щель при фонации овальной или линейной формы, со скоплением мокроты;
4. при подскладковом ларингите валикообразное утолщение слизистой оболочки под голосовыми складками.

Признаки по формам

1. катаральная форма: изменения преимущественно на голосовых складках, в межчерпаловидном или подскладковом пространстве; расширенные поверхностные сосуды, слизистый или слизисто-гнойный секрет, усиливающий охриплость;
2. отёчная форма: вся слизистая оболочка гортани гиперемирована и отёчна, смыкание голосовых складок неполное;
3. геморрагический ларингит на фоне гриппа или ОРВИ: кровоизлияния в слизистую оболочку, от петехий до небольших гематом.

Налёты

1. белый или беловато-жёлтый фибринозный налёт: переход в более тяжёлую, фибринозную форму;
2. налёт серого или бурого цвета: возможна дифтерия;
3. налёт у взрослого, не связанный с интубационной травмой: срочная дифференциальная диагностика с системными заболеваниями и туберкулёзом.

Инфильтративный ларингит, хондроперихондрит, абсцесс надгортанника

1. поражённый отдел гортани значительно инфильтрирован, гиперемирован, увеличен в объёме, малоподвижен, часто покрыт фибринозными налётами; в зоне формирования абсцесса просвечивает гной;
2. при тяжёлой форме и хондроперихондрите гортань болезненна при пальпации, хрящи малоподвижны, кожа над гортанью может быть инфильтрирована и гиперемирована;
3. абсцесс надгортанника: шаровидное образование на язычной поверхности надгортанника с просвечивающим гноем, выраженная боль и нарушение глотания.

3.4 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. оценка общего состояния и выявление воспалительной реакции.

Диагностические признаки

1. лейкоцитоз;
2. повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

При флегмонозном ларингите при госпитализации необходимо комплексное клинико-лабораторное обследование всех пациентов.

3.5 Микробиологическое исследование гнойного отделяемого

Посев на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителя и определением его чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. гнойное отделяемое: выбор адекватной терапии.

При поступлении в стационар проводится стандартное лабораторное обследование.

3.6 Пульсоксиметрия

Показания

1. дети младшего и дошкольного возраста: оценка степени дыхательной недостаточности и определение показаний к кислородотерапии.

3.7 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием

Показания

1. подозрение на гнойные осложнения (в стационаре);
2. затруднение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями гортани.

КТ целесообразна в условиях стационара при подозрении на гнойные осложнения или при затруднении дифференциальной диагностики с другими заболеваниями гортани. Если у ребёнка с признаками стеноза выполнение КТ невозможно, в сомнительных случаях проводится рентгенография шеи в прямой и боковой проекциях.

---

4. Лечение

Тактика лечения определяется формой и тяжестью воспалительного процесса.

4.1 Неосложнённый ларингит

1. При дисфонии любой степени рекомендуются ограничение голосовой нагрузки (исключение крика и шёпота **не менее 2 дней**) и лечебно-охранительный режим.
    1. при дисфонии полный голосовой покой **на 1–2 суток**, затем ограничение любой голосовой нагрузки;
    2. из рациона исключают острую, солёную, горячую и холодную пищу, спиртные напитки;
    3. отказ от курения.
2. При катаральном ларингите на фоне ОРВИ повышенное потребление жидкости не рекомендуется.

   Польза обильного питья сомнительна, тогда как повышенная в период заболевания секреция антидиуретического гормона способствует задержке жидкости.
3. При фебрильной лихорадке применяют противовоспалительные и жаропонижающие препараты (дозы — в таблице ниже).

   Детям с температурой тела выше 39–39,5 °C, помимо лекарственных средств, показаны физические методы охлаждения: раскрытие ребёнка и обтирание водой температуры 25–30 °C.
4. Детям противокашлевые и отхаркивающие препараты рутинно не назначают, за исключением случаев мучительного кашля.

   Перед назначением противокашлевых средств необходимо исключить состояния, при которых подавление кашля опасно и которые требуют специфического лечения, например бронхиальную обструкцию, а у детей также острый обструктивный ларингит (круп).
5. Проводят местную противовоспалительную терапию: вливания лекарственных препаратов в гортань и ингаляции.

   Для вливаний в гортань чаще всего используются антисептики из группы производных хинолина и четвертичных аммониевых соединений. Раствор подогревается до температуры тела и вливается по каплям, в

объёме до 2 мл.
Детям вливания в гортань не проводятся в связи с угрозой ларингоспазма.

6. Применяют небулайзерные ингаляции аэрозолей средней и низкой дисперсности (препараты — в таблице ниже).
   Продолжительность ингаляции, как правило, составляет 10 минут, интервал между ингаляциями различных препаратов около 30 минут. При наличии корок в гортани ингаляции начинаются с муколитика.
7. При аллергических заболеваниях (аллергический ринит, крапивница, поллиноз, аллергический конъюнктивит) назначают системные антигистаминные препараты.
8. Противогрибковые препараты назначают только после подтверждения кандидоза: взрослым — флуконазол 100 мг в сутки или итраконазол 100 мг 1 раз в сутки, **15 дней**.
9. Показана консультация физиотерапевта.

Жаропонижающие препараты

Препарат	Доза
Парацетамол	До 60 мг/кг в сутки. Детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не более 60 мг/кг в сутки.
Ибупрофен	До 30 мг/кг в сутки. Детям — 7,5 мг/кг каждые 6–8 часов, не более 30 мг/кг в сутки.

Препараты для ингаляций

Препарат	Доза
Ацетилцистеин (раствор для инъекций и ингаляций)	Ингаляционно по 1 ампуле (3 мл) 1–2 раза в сутки, 5–7 дней.
#Будесонид	Ингаляционно 1000 мкг 1–2 раза в сутки, курс 5–8 процедур.

Возможно применение готовых аптечных смесей на основе растительных препаратов с учётом противопоказаний и возраста: масла листьев эвкалипта прутовидного, а также 5–10% отваров цветков ромашки, листьев шалфея, травы тимьяна ползучего (чабреца), цветков календулы, листьев подорожника. Такие ингаляции могут быть тёплыми и холодными; продолжительность первой ингаляции составляет 1–2 минуты, последующих 5–10 минут.

Антигистаминные препараты

Препарат	Доза
Лоратадин, цетиризин	Детям 3–12 лет с массой тела более 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки, менее 30 кг — 5 мг 1 раз в сутки; взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки; старше 6 лет и взрослым — 5 мг 1 раз в сутки.
Дезлоратадин	От 6 до 12 месяцев — 1 мг, с 1 года до 5 лет — 1,25 мг, 6–11 лет — 2,5 мг, взрослым и детям старше 12 лет — 5 мг; кратность приёма 1 раз в сутки.

При дисфонии на фоне острого ларингита рекомендацией предусмотрено включение в терапию комплексных гомеопатических препаратов для уменьшения выраженности нарушений голоса. Приведённый в рекомендации препарат зарегистрирован по показанию «ларингиты различной этиологии» и применяется у взрослых и детей старше 6 лет с первых дней заболевания на 6 дней.

4.2 Системная антибактериальная терапия

1. При вирусной инфекции и длительности симптомов **менее 10 дней** антибактериальная терапия не назначается.
2. Системные антибиотики назначают при сохранении симптомов **в течение 10 дней** и при осложнённом течении.

Взрослым назначение антибиотика целесообразно при затяжном течении ларингита (10 дней и более), а также при выраженной инфильтрации голосовых складок и экссудации.

Антибактериальная терапия у взрослых

Препарат	Показание	Доза внутрь
Амоксициллин	Препарат выбора	500 мг 3 раза в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 1000 мг 3 раза в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернативный препарат; при факторах риска продукции бета-лактамаз	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	Альтернатива	400 мг 1 раз в сутки.
Цефдиторен	Альтернатива	400 мг; в таблице кратность зачёркнута, в тексте указано 1 раз в сутки.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	250–500 мг 2 раза в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	1000 мг 2 раза в сутки.

Взрослым антибиотик подбирают эмпирически и назначают внутрь.

Длительность курса

1. амоксициллин, амоксициллин + клавулановая кислота, цефиксим, джозамицин: 5–10 дней;
2. цефдиторен: 10 дней;
3. кларитромицин: 6 дней.

Факторами риска устойчивости пневмококка к бета-лактамам являются приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца, наличие в семье детей дошкольного возраста, посещающих детские учреждения, проживание в «закрытых» учреждениях. Амоксициллин с клавулановой кислотой предпочтителен при риске инфицирования возбудителем, продуцирующим бета-лактамазы (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis): при бронхиальной астме, сахарном диабете, хроническом бронхите, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет, при неэффективности предшествующего лечения амоксициллином.

> В тексте рекомендации цефдиторен назначается по 400 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней, тогда как в таблице 1 кратность его приёма зачёркнута целиком («2 раза в сутки 1 раз в сутки»).

Антибактериальная терапия у детей

Препарат	Показание	Доза
Амоксициллин	Препарат выбора	Внутрь 40–60 мг/кг в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 80–90 мг/кг в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернатива	Внутрь, суспензия 4:1 (125 мг + 31,25 мг в 5 мл или 250 мг + 62 мг в 5 мл) в 3 приёма каждые 8 часов; доза «45–60 мг/кг/сутки в 2–3 приёма» в таблице зачёркнута.
Цефиксим	Альтернатива	8 мг/кг в сутки 1 раз в сутки.
Цефтриаксон	Альтернатива	С 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки; при массе тела более 50 кг — дозы для взрослых.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	Внутрь 7,5 мг/кг в сутки в 2 приёма, не более 1000 мг в сутки.

Препарат	Показание	Доза
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	При невозможности применения бета-лактамов и макролидов	До 2 лет — по 125 мг 2 раза в сутки; 3–6 лет — по 250 мг 2 раза в сутки; 7–12 лет — по 250 мг 3 раза в сутки; взрослым — по 500 мг 2–3 раза в сутки; 10 дней.

Длительность курса у детей

1. амоксициллин: 5–7 дней;
2. амоксициллин + клавулановая кислота, цефиксим, джозамицин: 5–10 дней;
3. цефтриаксон: 6 дней;
4. кларитромицин: не более 14 дней;
5. тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат (внутримышечно): 10 дней.

Дозы для детей в тексте рекомендации (частично расходятся с таблицей 2):

1. амоксициллин: 40–60 или 80–90 мг/кг в сутки, 5–7 дней;
2. амоксициллин + клавулановая кислота: до 3 месяцев 30 мг/кг в сутки в 2 приёма; с 3 месяцев 25 мг/кг в сутки в 2 приёма или 20 мг/кг в сутки в 3 приёма; 5–10 дней;
3. цефиксим, суспензия: 8 мг/кг в сутки в 1–2 приёма, 5–10 дней;
4. цефтриаксон: с 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг 1 раз в сутки; при массе тела более 50 кг дозы для взрослых;
5. кларитромицин: 7,5–15 мг/кг в сутки в 2 приёма, не более 14 дней;
6. джозамицин: 50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма, 5–10 дней;
7. тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат: внутримышечно, 10 дней.

> Детские дозы в тексте и в таблице 2 не совпадают. Для кларитромицина в тексте указана «для детей старше 12 лет разовая доза» 7,5–15 мг/кг/сут, в таблице 7,5 мг/кг/сут в 2 приёма. Для амоксициллина с клавулановой кислотой в тексте приведена доза 20–30 мг/кг/сут, в таблице доза 45–60 мг/кг/сут зачёркнута и указана только суспензия в 3 приёма. Цефиксим в тексте назначается в 1–2 приёма, в таблице 1 раз в сутки. Для тиамфеникола возрастные группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет» не включают детей от 2 до 3 лет.

4.3 Флегмонозный, абсцедирующий, инфильтративный ларингит, хондроперихондрит гортани

1. Обязательная срочная госпитализация в учреждение с отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи (раздел «Показания к госпитализации»).
2. Антибактериальная терапия в стационаре начинается эмпирически с учётом региональной резистентности основных возбудителей; после улучшения состояния возможен переход на приём антибиотика внутрь (ступенчатая терапия). Препараты и дозы в таблице ниже.
3. Промывание полости абсцесса растворами антисептиков: 0,01% раствором бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорида моногидрата или гидроксиметилхиноксалиндиоксидом.
4. При дисфагии и тяжёлых формах проводят дезинтоксикационную терапию, коррекцию гиповолемии, назначают глюкокортикостероиды, парентеральное питание.
5. При осложнённых формах показано хирургическое лечение.

Препарат	Детям	Взрослым (осложнённый флегмонозный ларингит)
Амоксициллин + клавулановая кислота	С 3 месяцев внутривенно 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов, 5–10 дней	Внутривенно 1,2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 150 мг/кг в сутки в 4 введения	Внутривенно 2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней

Препарат	Детям	Взрослым (осложнённый флегмонозный ларингит)
Цефтриаксон	С 15 дней до 12 лет внутримышечно или внутривенно 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, 5–10 дней	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки, 7–10 дней
Цефепим	При тяжёлом флегмонозном ларингите и осложнениях в отделении реанимации: при массе тела более 40 кг — 2 г каждые 12 часов, до 40 кг — 50 мг/кг каждые 12 часов, 7–10 дней	—
Меропенем	В тех же условиях: от 3 месяцев до 12 лет — 10–20 мг/кг 3 раза в сутки, при массе тела более 50 кг — доза для взрослых, 5–10 дней	—
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	До 2 лет — 125 мг 2 раза в сутки, 3–6 лет — 250 мг 2 раза, 7–12 лет — 250 мг 3 раза в сутки	500 мг 2–3 раза в сутки, 10 дней

4.4 Стеноз гортани

1. Для профилактики стеноза проводят консервативную противовоспалительную терапию; дестенозирующая терапия — парентеральное введение глюкокортикоидов.
2. Детям с декомпенсированным стенозом гортани показана неотложная интубация трахеи.
3. При невозможности интубации выполняют трахеостомию или коникотомию.

> В комментарии о дестенозирующей терапии фраза оборвана: указана доза «60–120 мг», однако не указано, к какому глюкокортикоиду она относится и предназначена ли она для взрослых или для детей.

При неосложнённом остром ларингите хирургическое лечение не требуется.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациентам голосоречевых профессий после перенесённого острого ларингита показано наблюдение оториноларинголога до полного восстановления голосовой функции.

1. сроки нетрудоспособности продлевают до полного восстановления голоса;
2. неосложнённый ларингит разрешается за **7–14 дней**;
3. инфильтративные формы разрешаются **более 14 дней**.

Профилактика хронизации воспалительного процесса гортани заключается в своевременном лечении острого ларингита, повышении сопротивляемости организма, лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и инфекций верхних и нижних дыхательных путей, отказе от курения и соблюдении голосового режима.

Пациенту рекомендуют

1. ограничить голосовую нагрузку;
2. исключить горячую, холодную и острую пищу, спиртные напитки, курение и паровые ингаляции;
3. постоянно увлажнять воздух в помещении увлажнителем.

В составе комплексного лечения в рекомендации упоминаются противовирусные препараты.

> В разделе 7 и в памятке для пациента паровые ингаляции запрещены, тогда как в разделе 3.1 ингаляции отваров трав допускаются «тёплыми». Там же рекомендованы противовирусные препараты, однако в разделе о лечении такая рекомендация отсутствует.

5.1 Показания к госпитализации

Пациенты с острым ларингитом без стеноза гортани на фоне ОРВИ не нуждаются в госпитализации. Госпитализации подлежат все пациенты с осложнённым течением.

Обязательной срочной госпитализации в учреждение с отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи подлежат пациенты с осложнёнными и тяжёлыми формами:

1. флегмонозный ларингит;
2. абсцедирующий ларингит;
3. инфильтративный ларингит;
4. хондроперихондрит гортани.

Показанием к экстренной госпитализации является острая дыхательная недостаточность выше I степени.

Пациента выписывают при:

1. регрессе воспалительных изменений;
2. отсутствии дыхательной недостаточности;
3. отсутствии осложнений.

При неосложнённом ларингите прогноз благоприятный. При осложнённых формах со стенозом гортани решающее значение для сохранения жизни пациента имеют своевременная специализированная помощь и хирургическое лечение.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый ларингит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 01.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	`309_2` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Союз педиатров России
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для цефдиторена в тексте указано 400 мг 1 раз в сутки, в таблице 1 кратность зачёркнута целиком.
- Детские дозы кларитромицина, амоксициллина с клавулановой кислотой и цефиксима в тексте и в таблице 2 различаются; для кларитромицина «разовая доза» приведена в мг/кг/сут и «для детей старше 12 лет».
- Для тиамфеникола глицината ацетилцистеината не указана доза для детей от 2 до 3 лет: выделены только группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет».
- В комментарии о дестенозирующей терапии не назван глюкокортикоид, к которому относится доза «60–120 мг».
- Раздел 7 запрещает паровые ингаляции и рекомендует противовирусные препараты, тогда как раздел 3.1 допускает тёплые ингаляции и не содержит рекомендации о противовирусных препаратах.

Клинические рекомендации

Острый синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J01** — Острый синусит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/313_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз острого синусита у взрослых:

  Обязательные критерии

  1. острое начало заболевания;
  2. **два симптома и более**, из которых обязательно присутствуют заложенность носа и (или) выделения из носа, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки (постназальный синдром);
  3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

  Возможные симптомы

  1. боль или ощущение давления в проекции околоносовых пазух на лице;
  2. снижение или потеря обоняния.
- Диагноз острого синусита у детей:

  Обязательные критерии

  1. острое начало заболевания;
  2. **не менее двух** симптомов из перечисленных ниже;
  3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

  Симптомы

  1. заложенность носа;
  2. выделения из носа, в том числе стекание по задней стенке глотки (постназальный синдром);
  3. кашель.
- Системная антибактериальная терапия взрослым показана:
  1. при среднетяжёлом и тяжёлом течении;
  2. при лёгком течении рецидивирующего синусита с сохранением симптомов **5–7 дней и более**;
  3. при лёгком течении на фоне тяжёлой сопутствующей патологии или иммунодефицита.
- При впервые возникшем синусите стартовым препаратом является незащищённый аминопенициллин (амоксициллин). Если заметного эффекта нет **в течение 3 дней**, препарат заменяют.
- Местная терапия:
  1. промывание полости носа солевыми растворами;
  2. сосудосуживающие капли **не более 5–7 дней**;
  3. интраназальные глюкокортикостероиды пациентам **старше 12 лет**.
- Показания к экстренной госпитализации:
  1. тяжёлое течение;
  2. орбитальные или внутричерепные осложнения;
  3. отсутствие улучшения на фоне системной антибактериальной терапии **в течение 3–5 дней**;
  4. ухудшение состояния в любой момент.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острый синусит представляет собой острое воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух продолжительностью **менее 12 недель**, проявляющееся не менее чем двумя симптомами (перечислены в критериях диагноза ниже). Часть симптомов может быть заменена данными риноскопии, эндоскопии или компьютерной томографии (КТ).

Синусит считается рецидивирующим при 4 эпизодах и более за последний год, если между эпизодами имеются периоды не менее 8 недель без симптомов и без лечения.

Острый поствирусный синусит диагностируется при сохранении симптомов более 10 дней после острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и отсутствии признаков бактериального синусита. Как правило, он протекает легче и разрешается без антибактериальной терапии.

2.2 Критерии диагноза

У взрослых:

Обязательные критерии

1. острое начало заболевания;
2. **два симптома и более**, из которых обязательно присутствуют заложенность носа и (или) выделения из носа, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки (постназальный синдром);
3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

Возможные симптомы

1. боль или ощущение давления в проекции околоносовых пазух на лице;
2. снижение или потеря обоняния.

У детей:

Обязательные критерии

1. острое начало заболевания;
2. **не менее двух** симптомов из перечисленных ниже;
3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

Симптомы

1. заложенность носа;
2. выделения из носа, в том числе стекание по задней стенке глотки (постназальный синдром);
3. кашель.

Болевой синдром может отсутствовать. При верхнечелюстном синусите боль локализуется в проекции пазухи, реже в области переносицы и надбровья, и может иррадиировать в верхние зубы. Для сфеноидита характерна боль в центре головы и в затылочной области (каскообразная боль).

У детей синусит часто сочетается с гипертрофией и хроническим воспалением глоточной миндалины и может проявляться упорным кашлем или выраженным затруднением носового дыхания.

2.3 Степень тяжести

Форма	Признаки
Лёгкая	Лихорадка отсутствует. Умеренные симптомы, не влияющие или незначительно влияющие на качество жизни. Головная боль в проекции околоносовых пазух (ОНП) отсутствует. Осложнений нет
Среднетяжёлая	Выраженные симптомы, умеренно или значительно влияющие на качество жизни. Ощущение тяжести в проекции ОНП при движении или наклоне головы. Осложнение со стороны среднего уха (острый средний отит). Внутричерепные и орбитальные осложнения отсутствуют
Тяжёлая	Выраженные или мучительные симптомы. Болезненность в проекции ОНП, усиливающаяся при движении, наклоне головы, перкуссии. Внутричерепные или орбитальные осложнения

2.4 Классификация

В 90–98% случаев возбудителями синусита являются вирусы, на долю бактериального синусита приходится лишь 2–10%.

По этиологии выделяют вирусный, бактериальный, травматический, грибковый (в виде острого процесса встречается крайне редко) и смешанный синусит. Изолированный бактериальный синусит встречается редко; как правило, имеет место сочетание вирусов или вирусов и бактерий.

По локализации различают гайморит, фронтит, этмоидит и сфеноидит. Поражение всех пазух одной половины носа обозначается как гемисинусит, обеих половин как пансинусит.

---

3. Диагностика

3.1 Осмотр ЛОР-органов

Показания

1. всем пациентам при обращении к оториноларингологу и при госпитализации в стационар: общий осмотр и стандартный оториноларингологический осмотр.

Диагностические признаки при риноскопии

1. отделяемое в носовых ходах;
2. гиперемия и отёк слизистой оболочки полости носа;
3. отделяемое в среднем носовом ходе (передняя риноскопия) указывает на возможное поражение лобной и верхнечелюстной пазух, передних и средних клеток решётчатого лабиринта;
4. отделяемое в верхнем носовом ходе (задняя риноскопия) указывает на возможное поражение задних клеток решётчатого лабиринта и клиновидной пазухи.

Отсутствие отделяемого не исключает острого синусита: его может не быть при блоке естественных соустий и высокой вязкости секрета.

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Показания

1. оценка состояния полости носа и носоглотки;
2. дифференциальная диагностика.

В большинстве случаев эндоскопия не информативнее передней и средней риноскопии, но помогает отличить сфеноидит от аденоидита и выявить длительно находящееся инородное тело полости носа.

Диагностические признаки

1. гнойное отделяемое и (или) отёк слизистой оболочки в области остиомеатального комплекса; эти данные подтверждают диагноз.

3.3 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания к спиральной КТ

1. подозрение на внутричерепные или орбитальные осложнения;
2. затяжное тяжёлое течение;
3. сложные диагностические случаи.

Диагностические признаки

1. признаки воспаления в околоносовых пазухах и (или) в области остиомеатального комплекса; они подтверждают диагноз.

КТ является наиболее информативным методом: она показывает характер и распространённость изменений, а также анатомические особенности полости носа и пазух, ведущие к рецидивам, и визуализирует структуры, неразличимые на рентгенограмме.

3.4 Рентгенография околоносовых пазух

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение;
2. сложные диагностические случаи при невозможности выполнить КТ.

Диагностические признаки

1. утолщение слизистой оболочки пазухи;
2. горизонтальный уровень жидкости;
3. тотальное снижение пневматизации пазухи.

Интерпретацию затрудняют наложение окружающих костных структур и гипоплазия пазухи.

Данные рентгенографии и КТ совпадают лишь в 34% случаев, для верхнечелюстной пазухи в 77%.

3.5 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух

Показания

1. подозрение на верхнечелюстной или лобный синусит при невозможности выполнить рентгенографию и КТ.

3.6 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение.

Диагностические признаки

1. лейкоцитоз с нейтрофилёзом не является специфическим маркером бактериального синусита, однако его нарастание при повторном исследовании учитывают при решении вопроса о системной антибактериальной терапии.

3.7 Бактериологическое исследование

Посев гнойного отделяемого на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение у пациентов в стационаре;
2. затяжное течение;
3. неэффективность эмпирической антибактериальной терапии.

Забор материала

1. при верхнечелюстном синусите материал получают при пункции пазухи иглой Куликовского с аспирацией содержимого; если его нет, вводят стерильный 0,9% раствор натрия хлорида и аспирируют;
2. посев из носового хода нецелесообразен из-за попадания в материал посторонней микрофлоры.

Иные диагностические исследования не показаны.

3.8 Дифференциальная диагностика

У взрослых острый синусит дифференцируют с обострением хронического риносинусита, аллергическим и хроническими ринитами, у детей также с аденоидитом и инородным телом полости носа.

Заболевание	Общие с острым синуситом признаки	Отличия от острого синусита
Хронический риносинусит	Манифестация и обострения по клиническим проявлениям идентичны острому синуситу	1. назальные симптомы полностью не разрешаются в течение 12 недель даже на фоне лечения: пациенты отмечают улучшение, но не полное исчезновение симптомов; 2. у детей хронический риносинусит встречается значительно реже острого синусита; 3. в этиологии преобладают неинфекционные факторы: генетические аномалии, аллергия, аномалии строения полости носа.
Аллергический ринит	Сходные назальные симптомы: заложенность носа, выделения из носа, кашель вследствие постназального затекания. Аллергический ринит повышает риск острого синусита	1. симптомы повторяются; 2. значительно чаще беспокоят зуд в носу и (или) чихание; 3. характерны глазные симптомы (зуд в глазах, слезотечение), особенно при поллинозе; 4. в основе патогенеза лежит IgE-ассоциированное воспаление слизистой оболочки; 5. диагноз устанавливают по аллергологическому анамнезу, характеру симптомов и результатам специфического аллергологического обследования.
Аденоидит	Сходные назальные симптомы: заложенность носа, кашель вследствие постназального затекания, реже выделения из носа. У детей младше 10–12 лет воспаление в полости носа и околоносовых пазухах всегда сопровождается реактивным воспалением глоточной миндалины	1. у детей раннего и дошкольного возраста, не перенёсших аденотомию, при жалобах на «острый насморк» граница между острым синуситом и аденоидитом очень условна; 2. в отдельных случаях помогает эндоскопия полости носа и носоглотки: скопление отделяемого в среднем носовом ходе при небольшом его количестве в носоглотке больше характерно для острого синусита; 3. у дошкольников без признаков внутричерепных и орбитальных осложнений и без критериев острого бактериального синусита основным диагнозом целесообразно указывать аденоидит или острый назофарингит.

Заболевание	Общие с острым синуситом признаки	Отличия от острого синусита
Инородное тело полости носа	Родители ребёнка могут жаловаться на остро возникшую заложенность носа и (или) гнойные выделения из носа, особенно при инородном теле органического происхождения	1. трудности возникают, когда ребёнок незаметно для родителей вводит в нос органические вещества: кусочки пищи, семена растений, бумагу, поролон; 2. воспалительные изменения, как правило, односторонние, гнойные выделения появляются на фоне полного здоровья без предшествующего эпизода острого респираторного заболевания; 3. инородное тело выявляют при передней риноскопии после анемизации и аспирационного туалета полости носа, в ряде случаев при эндоскопии полости носа и носоглотки.

4. Лечение

4.1 Базисная терапия при любой степени тяжести

1. Промывание полости носа изотонической стерильной морской водой или солевыми растворами. Слабые гипертонические растворы применяют только в остром периоде, **не дольше 5–7 дней**.
2. Сосудосуживающие капли **не более 5–7 дней** из-за риска медикаментозного ринита. Нафазолин не применяют.
   Детям **до 6 лет**:
   1. фенилэфрин 0,125%;
   2. оксиметазолин 0,01–0,025%;
   3. ксилометазолин 0,05%: с 2 лет.
3. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) применяют при лихорадке, головной и лицевой боли.
   1. дети **до 6 лет**: только парацетамол (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофен (до 30 мг/кг в сутки);
   2. взрослые: возможен кетопрофен.
4. Назначают мукоактивные препараты, например ацетилцистеин или карбоцистеин. Перед назначением следует свериться с инструкцией: не все препараты разрешены при заболеваниях ЛОР-органов и в сочетании с антибиотиками.
5. Возможно применение растительных препаратов с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием: комбинации корня горечавки, цветков первоцвета, шалфея, цветков бузины и вербены, миртол, экстракт пеларгонии сидовидной.
6. Пациентам **старше 12 лет** для облегчения симптомов назначают комбинированные препараты с парацетамолом без психотропных компонентов.
7. Системные антигистаминные препараты применяют при сопутствующем аллергическом рините и в начальном периоде вирусной инфекции.
8. При вирусном синусите применяют противовирусные препараты, в том числе растительного происхождения.

4.2 Показания к системной антибактериальной терапии

Взрослым системная антибактериальная терапия показана при среднетяжёлом и тяжёлом течении. При лёгком течении её назначают только в следующих случаях:

1. рецидивирующий синусит с сохранением симптомов **5–7 дней и более**;
2. тяжёлая сопутствующая патология (например, сахарный диабет);
3. иммунодефицит.

Детям системная антибактериальная терапия показана при среднетяжёлом и тяжёлом течении и при признаках бактериального синусита. При лёгком течении её назначают при наличии хотя бы одного из условий:

1. орбитальные или внутричерепные осложнения;
2. **три признака** бактериального синусита и более (перечислены ниже);
3. иммунодефицит, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, некомпенсированный сахарный диабет I типа;
4. **4 эпизода** синусита и более за последний год.

О бактериальном синусите свидетельствуют **три признака и более**:

1. гнойные выделения или выделения только из одной половины носа **в течение 3 дней и более**;
2. головная боль или ощущение давления в проекции верхнечелюстных или лобных пазух;
3. температура тела **38,0 °C и выше**;
4. «вторая волна» заболевания;
5. лейкоцитоз **выше 15×10^9/л**.

На бактериальную этиологию указывают также выраженные с самого начала симптомы, сохраняющиеся 3–4 дня и угрожающие развитием орбитальных или внутричерепных осложнений.

4.3 Лёгкое течение

Базисная терапия, а также:

1. При гнойных выделениях (признаках бактериального воспаления) применяют местные антибактериальные препараты, в том числе в монотерапии. Эффект оценивают **через 3–4 дня**; если его нет, решают вопрос о системной антибактериальной терапии.

   Зарегистрированы для лечения синусита

   1. фрамицетин: детям с первых лет жизни;
   2. дексаметазон + неомицин + полимиксин B + фенилэфрин: с 2,5 лет.

   Введение растворов антибиотиков для инъекций в полость носа и пазухи не допускается.

   Для введения в пазуху и для ингаляционной терапии, особенно у детей, может применяться тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат: в комплексе с системными антибиотиками или в монотерапии.
2. Интраназальные глюкокортикостероиды пациентам **старше 12 лет** назначают в монотерапии при затяжном поствирусном синусите либо вместе с системными антибиотиками при показаниях к ним. Детям до 12 лет монотерапия допустима только при сопутствующем аллергическом рините.

   Для монотерапии синусита без признаков бактериальной инфекции в России зарегистрирован только спрей мометазона.
3. На амбулаторном этапе возможно применение комплексных гомеопатических препаратов по зарегистрированным показаниям.

4.4 Среднетяжёлое течение

Базисная терапия и системная антибактериальная терапия:

1. При впервые возникшем синусите стартовым препаратом является незащищённый аминопенициллин (амоксициллин).
   При высоком риске устойчивости пневмококка дозу амоксициллина увеличивают.

   Стартовыми препаратами являются защищённые аминопенициллины при

   1. сопутствующих заболеваниях;
   2. иммуносупрессии;
   3. возрасте **старше 65 лет**;
   4. неэффективности ранее назначенного амоксициллина.
2. Если заметного эффекта нет **в течение 3 дней**, препарат меняют, не дожидаясь окончания курса. У детей эффективность оценивают **через 48–72 часа**.
3. Пункцию верхнечелюстной пазухи выполняют при рентгенологически подтверждённом содержимом в пазухе, если лечение с системными антибиотиками **в течение 5–7 дней** не дало эффекта; при тяжёлом течении пункцию выполняют и без этого условия.
   Детям пункция и трепанопункция выполняются только в условиях стационара; во многих случаях вместо них возможно применение синус-катетера. Трепанопункцию у детей рассматривают только при тяжёлом течении фронтального синусита, с предварительной оценкой строения лобной пазухи по данным лучевых исследований.
4. Дренирование пазух, в том числе с помощью синус-катетера, показано при затяжном экссудативном синусите без обструкции соустий. При впервые возникшем неосложнённом синусите дренирование не показано.

Препараты, дозы и длительность курса приведены в таблице «Антибактериальные препараты и дозы» ниже.

4.5 Тяжёлое течение

Экстренная госпитализация в оториноларингологическое отделение (показания приведены в разделе «Показания к госпитализации»), базисная терапия и парентеральная антибактериальная терапия:

1. Взрослым при тяжёлом синусите вводятся цефотаксим или цефтриаксон, возможно также внутривенное введение амоксициллина с клавулановой кислотой. При риске анаэробной инфекции применяют клиндамицин в сочетании с цефалоспорином III поколения. При неэффективности стартовой парентеральной терапии рассматривается назначение цефоперазона с сульбактамом 2–4 г в сутки внутривенно в 2 введения, при резистентных штаммах препаратов резерва с учётом чувствительности.
2. Детям вводятся ампициллин с сульбактамом 300 мг/кг в сутки в 3–4 введения, цефтриаксон 75 мг/кг в сутки в 2 введения или цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 4 введения. При неэффективности этой терапии переходят на цефоперазон с сульбактамом 75–160 мг/кг в сутки в 2–4 введения (в КР со знаком #, то есть вне инструкции). При выделении резистентных штаммов целесообразен препарат из групп резерва (карбапенемы, оксазолидиноны, гликопептиды и др.) с учётом чувствительности выделенного микроорганизма.
3. При орбитальных или внутричерепных осложнениях показано хирургическое лечение в стационаре — вскрытие пазухи и дренирование абсцесса.
4. Бактериофаги назначают взрослым с острым бактериальным синуситом; местное применение оправдано при устойчивости возбудителя к антибиотикам или их непереносимости.
   Детям, находящимся на стационарном лечении, при выделении полирезистентных штаммов рассматривается терапия препаратом бактериофагов с высокой литической активностью в отношении выделенного микроорганизма.

4.6 Показания к плановому хирургическому лечению

При рецидивирующем синусите и предрасполагающих к нему изменениях перегородки носа или латеральной стенки полости носа показано плановое хирургическое лечение.

4.7 Антибактериальные препараты и дозы

Взрослые

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	500 мг × 3 р/сут — без факторов риска[1] 1000 мг × 3 р/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[2]	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут
Цефуроксим	250–500 мг × 2 р/сут
Цефиксим	400 мг × 1 р/сут
Цефдиторен внутрь	200 мг × 2 р/сут
Цефподоксим внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	250–500 мг × 2 р/сут
Левофлоксацин внутрь	500 мг × 1 р/сут
Моксифлоксацин внутрь	400 мг × 1 р/сут
Клиндамицин в/м (в КР со знаком #)	400–900 мг × 3 р/сут, 7–10 дней

[1] Риск устойчивости пневмококка повышают приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца, наличие в семье детей дошкольного возраста, посещающих детский сад, и проживание в закрытых учреждениях.

[2] Риск продукции бета-лактамаз (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis) повышают:

1. бронхиальная астма;
2. сахарный диабет;
3. хронический бронхит;
4. иммуносупрессия;
5. возраст **старше 65 лет**;
6. неэффективность предшествующей терапии амоксициллином.

Продолжительность лечения неосложнённого синусита составляет 7 дней, осложнённого 10–14 дней.

Макролиды являются препаратами резерва и применяются только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов. Фторхинолоны допустимы только у взрослых и только при отсутствии других вариантов; детям и подросткам они противопоказаны.

Дети

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	40–60 мг/кг/сут — без факторов риска[1] 80–90 мг/кг/сут — при факторах риска[1]

Препарат	Доза
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь	45–60 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Цефуроксим	30 мг/кг/сут в 2 приёма, не более 500 мг в сутки
Цефиксим	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен, цефподоксим (старше 12 лет) внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	15 мг/кг/сут в 2 приёма, макс. 1000 мг/сут
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат в/м (стационар, если β-лактамы невозможны)	125–250 мг 2–3 р/сут в зависимости от возраста

Амоксициллин с клавулановой кислотой предпочтителен, если за последние 3 месяца ребёнок получал антибиотики или посещает детский коллектив, а также при неэффективности амоксициллина **в течение 48–72 часов**. При лёгкой аллергии на пенициллины применяют цефалоспорины III поколения внутрь.

При лёгкой аллергии на пенициллины, кроме пероральных цефалоспоринов III поколения, возможно парентеральное введение:

1. цефтриаксон: 75 мг/кг/сут 1 раз в сутки;
2. цефотаксим: 50–100 мг/кг/сут в 2–3 введения.

Дозы из расчёта на килограмм массы тела предназначены для детей с массой тела менее 40 кг; при массе 40 кг и более используют дозы для взрослых.

Продолжительность лечения неосложнённого синусита составляет 7–10 дней, при орбитальных и внутричерепных осложнениях или рецидивирующем течении 10–14 дней.

> В тексте КР имеется расхождение: в разделе 3.1 стартовая доза амоксициллина для детей составляет 50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма, в таблице 5 указано 40–60 мг/кг в сутки (80–90 мг/кг при факторах риска). На сайте приведены данные таблицы.

Иное лечение (раздел 3.3) и медицинская реабилитация (раздел 4) не требуются.

4.8 Профилактика

Детям из групп риска по респираторным заболеваниям рекомендованы местные и системные лизаты бактерий.

4.9 Особые случаи

Сопутствующий аллергический ринит способствует затяжному течению синусита; в этом случае необходимы системные антигистаминные препараты и более высокая доза глюкокортикостероидов.

Лечение одонтогенного синусита хирургическое, с удалением пломбировочного материала и секвестров. Из антибактериальных препаратов предпочтительны респираторные фторхинолоны, поскольку преобладает анаэробная микрофлора.

5. Показания к госпитализации. Осложнения

Показания к экстренной госпитализации в оториноларингологическое отделение

1. при тяжёлом течении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями;
2. при отсутствии улучшения на фоне системной антибактериальной терапии **в течение 3–5 дней**;
3. при прогрессирующем ухудшении состояния в любой момент.

Орбитальные и внутричерепные осложнения свидетельствуют о тяжёлом течении, острый средний отит — о среднетяжёлом.

Критерии выписки
Стабильно удовлетворительное состояние **в течение не менее 3 последних дней**.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый синусит»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (карточка рубрикатора на 22.10.2026); год окончания действия не указан
Актуализация	По правилу из самой КР — «не реже чем один раз в три года» (прил. А2): следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	313_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети
Целевая аудитория	Оториноларингологи, терапевты, педиатры

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Детская доза амоксициллина: в тексте раздела 3.1 указано 50–60 мг/кг/сут, в таблице 5 указано 40–60 (80–90) мг/кг/сут.
- Пометка off-label стоит там, где в КР у препарата знак #; в этой КР он не расшифрован. ⚠ В российских КР им, как правило, обозначается применение вне инструкции; это следует проверить по инструкции к препарату.

6.2 Шкалы доказательности

Шкала	Интерпретация
УУР А	Сильная рекомендация: все критерии эффективности являются важными, исследования высокого или удовлетворительного качества, выводы согласованы
УУР В	Условная рекомендация: не все критерии эффективности являются важными, не все исследования высокого качества и/или выводы не согласованы
УУР С	Слабая рекомендация: доказательства надлежащего качества отсутствуют
УДД 1–5	Для лечения: от 1 (систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований с метаанализом) … до 5 (только обоснование механизма действия или мнение экспертов). Для диагностики используется отдельная шкала (табл. П1); точная расшифровка открывается при нажатии на бейдж

Клинические рекомендации

Острый тонзиллит и фарингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J02** — Острый фарингит **J02.0** — Стрептококковый фарингит **J02.8** — Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями **J02.9** — Острый фарингит неуточненный **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J03.0** — Стрептококковый тонзиллит **J03.8** — Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями **J03.9** — Острый тонзиллит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 31.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/306_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Возбудителями тонзиллофарингита в большинстве случаев являются вирусы, и антибактериальная терапия при этом не показана. Из бактериальных возбудителей лечения требует только бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА); выделение из зева стафилококка, пневмококка и других микроорганизмов расценивается как колонизация.
- По клинической картине отличить вирусный тонзиллофарингит от бактериального невозможно. Пациентам **старше 3 лет** выполняют экспресс-тест на БГСА; при отрицательном результате у ребёнка его подтверждают бактериологическим исследованием (посевом).
- Антибактериальная терапия назначается только при доказанной или высоковероятной стрептококковой этиологии. При вирусной инфекции антибиотики неэффективны и не предотвращают присоединения бактериальной инфекции.
- Препаратом выбора является амоксициллин, курс лечения составляет **10 дней**.
- При отсутствии улучшения **через 48–72 часа** от начала антибактериальной терапии следует пересмотреть диагноз: заболевание может быть обусловлено острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) или инфекционным мононуклеозом.
- Тяжёлое состояние и отказ от еды и питья, требующий инфузионной терапии, являются показаниями к госпитализации в инфекционное отделение. Неэффективность лечения и подозрение на гнойное осложнение требуют консультации оториноларинголога и госпитализации в хирургическое отделение; полный перечень приведён в разделе «Показания к госпитализации».
- Рутинно не показаны:
  1. определение С-реактивного белка (СРБ) и прокальцитонина;
  2. общий анализ крови в амбулаторных условиях;
  3. исследование антистрептолизина О (АСЛ-О);
  4. контрольный мазок после лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острый тонзиллофарингит является острым инфекционным воспалением слизистой оболочки и лимфоидной ткани ротоглотки (нёбных миндалин и лимфоидных фолликулов задней стенки глотки). Термин объединяет острый тонзиллит и острый фарингит, поскольку чаще в воспалительный процесс вовлекаются оба отдела.

По локализации (преимущественно поражённый отдел ротоглотки)

1. тонзиллит;
2. фарингит;
3. тонзиллофарингит.

По этиологии

1. стрептококковый;
2. нестрептококковый (вирусный).

Тактика лечения определяется этиологией.

2.2 Клиническая картина

Заболевание начинается остро.

1. повышение температуры тела **выше 38 °C**, реже температура нормальная или субфебрильная;
2. боль в горле, усиливающаяся при глотании, возможна иррадиация в ухо;
3. увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов;
4. у детей младшего возраста отказ от еды.

Состояние удовлетворительное или средней тяжести.

2.3 Чувствительность возбудителя и колонизация

Все штаммы БГСА чувствительны к пенициллину и всем бета-лактамам. Устойчивость к макролидам выявляется примерно у каждого пятого штамма, к клиндамицину у 3–4%.

Выделение из зева *S. aureus*, *S. pneumoniae* или других бактерий при клинической картине тонзиллофарингита расценивается как колонизация и не требует назначения антибиотиков.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

1. жалобы на выраженную боль в горле при глотании;
2. данные осмотра: гиперемия, инфильтрация и отёк миндалин, увеличение регионарных лимфатических узлов;
3. результаты экспресс-теста на БГСА или бактериологического исследования.

3.2 Фарингоскопия и общий осмотр

Показания

1. каждый пациент: осмотр оториноларинголога, педиатра, врача общей практики или терапевта.

Признаки стрептококковой этиологии

1. увеличение подчелюстных или переднешейных лимфатических узлов;
2. высокая температура тела;
3. выраженная боль в горле;
4. «пылающий зев»;
5. налёт на миндалинах;
6. отсутствие насморка, кашля и конъюнктивита.

Признаки вирусной этиологии

1. насморк;
2. конъюнктивит;
3. кашель;
4. при инфекции вирусом Эпштейна — Барр генерализованная лимфаденопатия, увеличение печени и селезёнки.

Петехии на мягком нёбе встречаются как при стрептококковой инфекции, так и при инфекции вирусом Эпштейна — Барр.

Также следует учитывать

1. У детей **старше 3 лет** насморк, кашель, охриплость и конъюнктивит при стрептококковой инфекции встречаются не более чем у 10% пациентов и только при сопутствующей вирусной инфекции.
2. Симметричное увеличение миндалин отличает тонзиллофарингит от паратонзиллярного абсцесса.

3.3 Экспресс-тест на БГСА

Показания

1. пациенты **старше 3 лет**.

Детям **до 3 лет** экспресс-тест рутинно не проводится; исключением является стрептококковый тонзиллит у кого-либо из окружения ребёнка, например у старшего брата или сестры.

Оценка результата

1. положительный результат: посев не требуется;
2. отрицательный результат у взрослых: посев не требуется;
3. отрицательный результат у детей и подростков: результат подтверждают бактериологическим исследованием.

3.4 Бактериологическое исследование мазка из зева

Показания

1. пациенты **старше 3 лет**, если экспресс-тест не проводился или его результат отрицательный.

Результат готов **в течение 72 часов**.

Забор материала

1. до начала антибактериальной терапии;
2. до утренней гигиены полости рта, натощак или **через 2 часа** после еды;
3. под контролем орофарингоскопии, без касания зубов и языка;
4. из устьев крипт миндалин и с задней стенки глотки.

3.5 Бактериологическое исследование на коринебактерию дифтерии

Посев слизи и плёнок с миндалин на палочку дифтерии рутинно не выполняется, учитывая благоприятную эпидемиологическую обстановку.

Показания

1. неблагоприятный эпидемиологический анамнез;
2. неблагоприятный вакцинальный анамнез;
3. характерная клиническая симптоматика.

3.6 Дифференциальная диагностика стрептококкового и вирусного тонзиллофарингита

Дифференциальную диагностику стрептококкового и вирусного тонзиллофарингита проводят у каждого пациента. Шкалы позволяют выявить пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции.

Шкала Центора в модификации МакАйзека

Признак	Баллы
Температура тела выше 38 °C	1
Отёчность и гиперемия миндалин, налёты на задней стенке глотки и миндалинах	1
Отсутствие катаральных явлений и кашля	1

Признак	Баллы
Переднешейный и/или подчелюстной лимфаденит	1
Возраст 5–14 лет / 15–44 года / 45 лет и старше	1 / 0 / −1

Баллы	Вероятность БГСА: ≥15 лет / 3–14 лет	Лечебная тактика
0–1	7–12% / 8–14%	Посев и/или антибактериальная терапия не показаны
2–3	21–38% / 23–37%	Антибактериальная терапия по результатам экспресс-теста и/или посева
4 и более	57% / 55%	Антибактериальная терапия на основании клинической картины

Шкала FeverPAIN

По одному баллу начисляется за каждый признак: повышение температуры тела за последние сутки, налёт на миндалинах, обращение в первые 3 дня в связи с выраженными симптомами, выраженные гиперемия и отёк миндалин, отсутствие кашля и насморка.

Вероятность стрептококковой инфекции групп A, C или G составляет 16% при 0–2 баллах, 43% при 3 баллах, 63% при 4–5 баллах.

Шкалы позволяют выявить пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции, однако не дают возможности установить диагноз с абсолютной точностью.

3.7 Дифференциальная диагностика с другими заболеваниями

Заболевание	Отличительные признаки
Инфекционный мононуклеоз	чаще болеют подростки и лица молодого возраста **до 30 лет**; слабость, лимфаденопатия, увеличение печени и селезёнки, атипичные мононуклеары в периферической крови; диагноз подтверждается полимеразной цепной реакцией (ПЦР) на ДНК вируса Эпштейна — Барр и выявлением IgM к капсидному антигену
Энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой (синдром «рука — нога — рот»)	дети **до 5 лет**, как правило в летний период; везикулы на слизистой оболочке полости рта без налётов на миндалинах, сыпь на кистях и стопах
Ангина Симановского — Плаута — Венсана	некротическая язва на одной миндалине, гнилостный запах
Дифтерия зева	плотный налёт, снимается с трудом, после снятия остаётся кровоточащая поверхность
Синдром Маршалла (PFAPA)	периодическая лихорадка **до 39–40 °C** в сочетании с тонзиллитом или фарингитом, афтозным стоматитом и шейным лимфаденитом; приступы повторяются каждые 1–2 месяца, средний возраст детей 5 лет; приступ быстро купируется системными кортикостероидами

3.8 Исследования, не показанные рутинно

С-реактивный белок и прокальцитонин

В амбулаторных условиях определение СРБ и прокальцитонина не позволяет отличить вирусное воспаление от бактериального.

Показания

1. СРБ определяют при госпитализации в стационар;
2. прокальцитонин — по показаниям у тяжёлых пациентов в стационаре.

Общий анализ крови

Общий анализ крови в амбулаторных условиях рутинно не выполняют.

Показания

1. исключение инфекционного мононуклеоза и другие показания.

Антистрептолизин О

АСЛ-О применимо только для ретроспективной диагностики: его уровень повышается лишь **на 7–9-й день**.

Показания

1. подозрение на ревматическую лихорадку;
2. подозрение на гломерулонефрит;
3. подозрение на детские аутоиммунные нейропсихиатрические расстройства, ассоциированные со стрептококковой инфекцией (PANDAS).

Контрольный мазок на БГСА после лечения

Рутинно контрольный мазок после лечения не показан.

Показания

1. высокий риск ревматической лихорадки;
2. рецидив симптомов.

---

4. Лечение

4.1 Вирусный тонзиллофарингит

1. Системные антибактериальные препараты не применяют: они неэффективны и не предотвращают присоединения бактериальной инфекции.
2. Профилактическое назначение антибиотиков не рекомендуется.
3. Симптоматическая терапия (ниже).

4.2 Стрептококковый тонзиллофарингит

1. Антибактериальную терапию назначают только при доказанной или высоковероятной стрептококковой этиологии.
2. Препарат выбора: амоксициллин.

   При инфекционном мононуклеозе на фоне приёма амоксициллина возможно появление сыпи, однако она возникает и при приёме других антибиотиков, и без них, поэтому при мононуклеозе следует избегать назначения любых системных антибактериальных препаратов.
3. Курс пенициллинов, цефалоспоринов, линкозамидов и макролидов, кроме азитромицина, составляет **10 дней**.
4. Если **через 48–72 часа** от начала антибактериальной терапии температура тела и боль в горле не уменьшились, следует пересмотреть диагноз: наиболее вероятны ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.

   Неэффективность лечения является показанием к консультации оториноларинголога и госпитализации в хирургическое отделение.

5. При рецидивирующем стрептококковом тонзиллофарингите препаратами выбора являются амоксициллин с клавулановой кислотой или клиндамицин (детям **старше 3 лет**) курсом **10 дней**. Необходима консультация оториноларинголога для исключения хронического тонзиллита, у детей также синдрома PFAPA.
6. При нетяжёлой аллергии на пенициллины назначают цефалоспорины II–III поколения (цефуроксим, цефиксим, цефдиторен, цефподоксим). Перекрёстная аллергия с пенициллинами встречается менее чем в 2% случаев для цефалоспоринов II поколения и менее чем в 1% для III поколения.

   Уровни доказательности в рекомендации различаются

   1. цефуроксим: УУР С, УДД 5;
   2. цефиксим: С и 5 у детей, В и 1 у взрослых;
   3. цефдиторен: С и 2;
   4. цефподоксим: В и 2.

   Курс лечения **10 дней**.
7. При аллергии на цефалоспорины или тяжёлой реакции на бета-лактамы (анафилактический шок, отёк гортани, тяжёлая крапивница) назначают макролиды или линкозамиды с учётом возможной устойчивости стрептококка к макролидам.
8. Бензатина бензилпенициллин вводят однократно внутримышечно вместо курса приёма внутрь только при сомнениях в том, что пациент будет принимать препарат. Доза для детей с массой тела до 27 кг составляет 600 тысяч ЕД, более 27 кг 1,2 миллиона ЕД.

4.3 Дозы для приёма внутрь

Препарат	Взрослые	Дети
Стартовая терапия, 10 дней		
Амоксициллин[1]	1,5 г/сут в 3 приёма или 1,0 г/сут в 2 приёма	50 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Альтернатива		
Бензатина бензилпенициллин[2] **в/м, однократно**	2,4 млн ЕД	менее 27 кг — 600 тыс. ЕД; более 27 кг — 1,2 млн ЕД
Цефалексин	старше 10 лет: 500–1000 мг/сут в 2 приёма	3–10 лет, только таблетки: 25–50 мг/кг/сут в 4 приёма, не более 1000 мг/сут
Рецидив и/или неэффективность амоксициллина		
Амоксициллин + клавулановая кислота[1 3] **(во время еды)**	1750 мг/сут по амоксициллину в 2 приёма	50 мг/кг/сут по амоксициллину в 2–3 приёма
Нетяжёлая аллергия на пенициллины		
Цефуроксим (сразу после еды)	1,0 г/сут в 2 приёма	20 мг/кг/сут в 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1–2 приёма	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен (после еды)	400 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 400 мг/сут в 2 приёма
Цефподоксим (во время еды)	200 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 200 мг/сут в 2 приёма
Аллергия на цефалоспорины и/или тяжёлая реакция на пенициллины		

Препарат	Взрослые	Дети
Кларитромицин	500–1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма
Джозамицин (между едой)	1,0 г/сут в 2 приёма	40–50 мг/кг/сут в 2 приёма
Азитромицин (за 1 час до еды)	500 мг/сут в 1 приём, **3 дня**	20 мг/кг/сут в 1 приём, 3 дня
Мидекамицин (за 1 час до еды)	1,2 г/сут в 3 приёма	старше 3 лет: 50 мг/кг/сут в 2 приёма
Спирамицин	6 млн МЕ/сут в 2 приёма	старше 6 лет, более 20 кг: 300 тыс. МЕ/кг/сут в 2 приёма
Клиндамицин (запивать большим объёмом воды)	0,6 г/сут в 4 приёма	20 мг/кг/сут в 3 приёма

[1] С осторожностью при подозрении на инфекционный мононуклеоз. [2] При сомнениях в соблюдении пациентом назначений, ревматической лихорадке у пациента или его родственников, неблагоприятных бытовых условиях и вспышках инфекции в коллективе. [3] Доза клавулановой кислоты не должна превышать 10 мг/кг в сутки из-за риска диареи.

Дозы цефуроксима, амоксициллина у детей, амоксициллина с клавулановой кислотой и клиндамицина в тексте КР отличаются от таблицы 1: подробности в слое «Подробнее» и в разделе «Неточности и противоречия в тексте рекомендации».

> Текст КР и таблица 1 расходятся. Цефуроксим взрослым: в тексте 250 мг 2 раза в сутки, в таблице 1,0 г в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 40 мг/кг в сутки, в таблице 50 мг/кг. Амоксициллин детям: в тексте 50 мг/кг в сутки в 2 приёма, не более 1000 мг в сутки, в таблице в 2–3 приёма без ограничения. Клиндамицин: в тексте взрослым 300 мг 2 раза в сутки, детям 3–12 лет 20–30 мг/кг в сутки, в таблице 0,6 г в сутки в 4 приёма и 20 мг/кг. Выбор дозы остаётся за врачом; дозы следует сверить с инструкцией в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

4.4 Парентеральная терапия

Если пациент не может или не хочет принимать препарат внутрь, антибиотик вводится парентерально до стабилизации состояния с последующим переходом на пероральный приём.

Препарат	Дети	Взрослые
Ампициллин	до 1 года 100 мг/кг/сут; 1–4 года 100–150 мг/кг/сут; от 4 лет 1–2 г/сут; в 4 введения	и дети более 40 кг: 250–500 мг каждые 6 ч
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в	90 мг/кг/сут в 3 введения	и дети старше 12 лет: 1,2 г каждые 8 ч
Ампициллин + сульбактам	до 12 лет или менее 40 кг: 150 мг/кг/сут в 3–4 введения	1,5–3 г каждые 6–8 ч
Цефазолин	1 мес — 18 лет: 25–50 мг/кг/сут (при тяжёлом течении — 100) в 3–4 введения	2,0 г каждые 8 ч
Цефтриаксон	до 12 лет: 20–80 мг/кг/сут 1 раз (более 50 кг — до 2 г/сут)	и дети старше 12 лет: 2 г 1 раз в сутки
Цефотаксим	до 12 лет: 100–150 мг/кг/сут в 2–4 введения	и дети старше 12 лет или более 50 кг: 1–2 г каждые 6–8 ч

Препарат	Дети	Взрослые
Клиндамицин (непереносимость β-лактамов)	20–40 мг/кг/сут в 3–4 введения	0,4–0,6 г каждые 6–8 ч

4.5 Симптоматическая терапия

При лихорадке и болевом синдроме применяют ибупрофен, парацетамол или, у пациентов **старше 15 лет**, ацетилсалициловую кислоту; детям применяют только парацетамол и ибупрофен.

Здоровым детям старше 3 месяцев жаропонижающие назначают при температуре

1. **выше 39,0 °C** при измерении в прямой кишке;
2. **выше 38,5 °C** в подмышечной впадине.

Ибупрофен

1. взрослые: 200–400 мг;
2. дети: 7,5 мг/кг каждые 6–8 часов, не более 30 мг/кг в сутки.

Парацетамол

1. взрослые: 500–1000 мг;
2. дети: 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не более 60 мг/кг в сутки.

Ацетилсалициловая кислота

1. взрослые и дети старше 15 лет: 0,5–1 г, не более 3 г в сутки.

Кетопрофен

1. взрослые и дети старше 15 лет: 100 мг 1–2 раза в сутки внутрь или ректально;
2. лизиновая соль, гранулы для раствора внутрь, взрослые и дети старше 14 лет: 80 мг 2–3 раза в сутки;
3. лизиновая соль, дети от 6 до 14 лет: 40 мг 2–3 раза в сутки.

Системные кортикостероиды при боли в горле рутинно не назначаются.

Исключением являются выраженный дискомфорт и угроза асфиксии, например при инфекционном мононуклеозе. В этом случае однократно внутрь назначается #дексаметазон 0,3 или 0,6 мг/кг или #преднизолон 1 мг/кг (УУР В, УДД 1).

При выраженном болевом синдроме используют местные анестетики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в виде спреев, растворов и таблеток для рассасывания с учётом возраста. При стрептококковой инфекции местное лечение не заменяет системную антибактериальную терапию.

Возрастные ограничения

1. бензидамин: с 3 лет;
2. бензокаин + хлоргексидин: старше 4 лет;
3. бензоксония хлорид + лидокаин: старше 4 лет;
4. амилметакрезол + дихлорбензиловый спирт + лидокаин: старше 12 лет;
5. флурбипрофен: старше 12 лет;
6. кетопрофен: с 12 лет;
7. лидокаин + лизоцим + цетилпиридиния хлорид: старше 18 лет;
8. флурбипрофен + цетилпиридиния хлорид: старше 18 лет;
9. бензилдиметил-миристоиламинопропиламмоний + флурбипрофен: старше 18 лет.

Из-за риска реактивного ларингоспазма препараты для лечения заболеваний горла назначают с **3–4 лет**. Детям, не умеющим полоскать горло, предпочтителен спрей. «Смазывание» миндалин и механическое удаление налётов не рекомендуются.

Дополнительно, в том числе курсами в межрецидивный период, возможно применение растительных препаратов: корня алтея, ромашки, тысячелистника, коры дуба, хвоща, листьев грецкого ореха, одуванчика.

Рекомендуется ограничение раздражающей пищи (острой, кислой, солёной, горячей и холодной); пища должна иметь мягкую консистенцию.

При неосложнённом тонзиллофарингите хирургическое лечение не рекомендуется.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации. Осложнения

После тесного бытового контакта с больным стрептококковой инфекцией антибиотикопрофилактика показана:

1. беременным со сроком гестации **37 недель и более**;
2. новорождённым и родильницам **в первые 28 дней**;
3. лицам в возрасте **75 лет и старше**.

Тесным бытовым контактом считается длительный контакт с больным в домашних условиях в течение **7 дней** до появления симптомов и (или) в первые **24 часа** после начала антибактериальной терапии.

Больные стрептококковым тонзиллофарингитом подлежат изоляции от организованных коллективов, их контакты ограничиваются.

Для профилактики рецидивов тонзиллофарингита применяют лизаты бактерий.

При рецидивирующем тонзиллофарингите применяются биологически активные добавки (БАД), содержащие естественные бактерии ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

После стрептококкового тонзиллофарингита пациент находится под наблюдением **в течение месяца**:

1. общий анализ крови и мочи **через 7–10 дней** и **через 3 недели**;
2. электрокардиография (ЭКГ) при жалобах со стороны сердца.

При отсутствии отклонений пациента снимают с диспансерного учёта **через месяц**.

Детям при отклонениях после выписки показана консультация

1. изменения в общем анализе мочи: нефролог;
2. клинические или лабораторные признаки ревматической лихорадки: ревматолог;
3. признаки вовлечения сердечно-сосудистой системы: детский кардиолог.

Лечение, как правило, амбулаторное. На фоне антибактериальной терапии улучшение наступает **через 12–24 часа**. Ребёнок допускается в детский коллектив после полного выздоровления.

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализация в инфекционное отделение (при его отсутствии в боксированное педиатрическое отделение)

1. тяжёлое состояние;
2. отказ от еды и питья, требующий инфузионной терапии.

Консультация оториноларинголога и госпитализация в хирургическое отделение

1. неэффективность лечения;
2. подозрение на гнойное осложнение: паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит;
3. атипичная фарингоскопическая картина (подозрение на новообразование);
4. необходимость хирургического вмешательства: дренирование абсцесса, биопсия, тонзиллэктомия.

Критерии выписки

1. устойчивое купирование проявлений болезни;
2. отсутствие угрозы жизни и здоровью пациента.

Гнойные осложнения стрептококковой инфекции

1. паратонзиллярный абсцесс;
2. парафарингеальный абсцесс;
3. ретрофарингеальный абсцесс;
4. гнойный лимфаденит.

Негнойные осложнения

1. острая ревматическая лихорадка;
2. ревматическая болезнь сердца;
3. постстрептококковый гломерулонефрит;
4. стрептококковый токсический шок;
5. PANDAS.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 31.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	`306_3` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Дозы цефуроксима, амоксициллина, амоксициллина с клавулановой кислотой и клиндамицина в тексте и в таблице 1 различаются; расхождения приведены в слое «Подробнее» блока «Лечение».
- Ацетилсалициловая кислота у детей упоминается с 15 лет, а кетопрофен в гранулах дозирован для детей с 6 лет, хотя в том же комментарии сказано, что в педиатрической практике следует ограничиться парацетамолом и ибупрофеном; интервал приёма ибупрофена указан как «каждые 6-6-8 ч».
- В таблице 1 у бензатина бензилпенициллина в колонке «Дети» указано «у пациентов старше 12 лет при m<27 кг 600 тыс. ед»; по смыслу это дозировка по массе тела, как в тексте КР.

Клинические рекомендации

Отит средний острый

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.0** — Острый средний серозный отит **H65.1** — Другие острые негнойные средние отиты **H66.0** — Острый гнойный средний отит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/314_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Острый средний отит (ОСО) является воспалительным процессом, охватывающим все три отдела среднего уха: барабанную полость, клетки сосцевидного отростка и слуховую трубу. Заболевание проявляется болью в ухе, повышением температуры тела, снижением слуха, в ряде случаев гноетечением из уха.
- Диагноз острого среднего отита:

  Обязательные критерии (все три одновременно)

  1. острое начало заболевания;
  2. воспалительные изменения барабанной перепонки: гиперемия, инфильтрация;
  3. признаки выпота в барабанной полости: выбухание барабанной перепонки или снижение её подвижности при пневмоотоскопии или тимпанометрии.

  Диагноз подтверждает также внезапно возникшая оторея при исключённом наружном отите.
- Показания к системной антибактериальной терапии:
  1. возраст **до 2 лет**: во всех случаях при клинических признаках отита;
  2. гнойная форма независимо от возраста;
  3. сохранение симптомов **более 72 часов**;
  4. рецидивирующее течение;
  5. отягощающая сопутствующая патология;
  6. невозможность повторного осмотра пациента.
- Препаратом первой линии является амоксициллин. При отсутствии эффекта **в течение 3 дней** его заменяют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим. Курс составляет **7–10 дней**.
- Для обезболивания используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол; ушные капли с лидокаином и феназоном допустимы только при отсутствии перфорации барабанной перепонки.
- Показания к экстренной госпитализации:
  1. тяжёлое течение;
  2. отсутствие положительной динамики при лёгком течении на фоне адекватной терапии **в течение 3–5 дней**;
  3. прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.
- **Через 3–4 недели** пациента повторно осматривают с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы своевременно выявить экссудативный средний отит.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Острый средний отит: воспаление всех трёх отделов среднего уха (барабанной полости, клеток сосцевидного отростка и слуховой трубы); поражается только слизистая оболочка.

Проявляется одним или несколькими симптомами

1. боль в ухе;
2. повышение температуры тела;
3. снижение слуха;
4. в ряде случаев гноетечение.

Рецидивирующим считается отит при 3 и более эпизодах за 6 месяцев или 4 и более эпизодах за 12 месяцев.

Затянувшимся считается отит, при котором симптомы воспаления среднего уха сохраняются **в течение 3–12 месяцев** после одного или двух курсов антибактериальной терапии.

У детей возможны возбуждение, раздражительность, рвота и диарея. Заболевание, как правило, длится не более трёх недель.

2.2 Стадии

1. острый евстахеит;
2. острое катаральное воспаление;
3. доперфоративная стадия острого гнойного воспаления;
4. постперфоративная стадия острого гнойного воспаления;
5. репаративная стадия.

Отоскопическая картина каждой стадии приведена в разделе «Диагностика».

2.3 Степень тяжести

Лёгкое течение	**Тяжёлое течение**
Осложнения отсутствуют	Интратемпоральные или внутричерепные осложнения
Выбухание барабанной перепонки отсутствует	Выраженное выбухание барабанной перепонки
Непродолжительная боль в ухе, хорошо купируется лекарственными средствами	Выраженный болевой синдром (у детей раннего возраста проявляется изменением поведения), плохо купируется или не купируется лекарственными средствами
Общее состояние не изменено: сон, аппетит и активность не нарушены	Общее состояние изменено
Нормальная температура тела или субфебрилитет не более 3 дней	Субфебрилитет более 3 дней или температура тела выше 38,0 °C

2.4 Клиническая картина

Дети старше 2 лет

1. остро возникшая боль в ухе;
2. воспалительные изменения барабанной перепонки: гиперемия, выбухание, снижение подвижности при пневмоотоскопии;
3. оторея в постперфоративной стадии.

Дети раннего возраста

1. выбухание барабанной перепонки;
2. изменения поведения: беспокойство, отказ от еды, ребёнок теребит и трёт ухо.

Взрослые пациенты чаще предъявляют жалобы на заложенность уха, аутофонию и шум в ухе.

Снижение слуха носит кондуктивный характер; сенсоневральный компонент присоединяется редко.

2.5 Возбудитель и выбор антибактериального препарата

Возбудителя в ряде случаев можно предположить по клинической картине. При сочетании отита с конъюнктивитом наиболее вероятным возбудителем является H. influenzae. Стремительное начало с лихорадкой, спонтанной перфорацией и симптомами со стороны дыхательных путей характерно для S. pyogenes, нарастающая боль, лихорадка и спонтанная перфорация характерны для S. pneumoniae.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Обязательные критерии (все три одновременно)

1. острое начало заболевания;
2. воспалительные изменения барабанной перепонки: гиперемия, инфильтрация;
3. признаки выпота в барабанной полости: выбухание барабанной перепонки или снижение её подвижности при пневмоотоскопии или тимпанометрии.

Диагноз подтверждает также внезапно возникшая оторея при исключённом наружном отите.

3.2 Отоскопия

Отоскопию выполняют всем пациентам при первичном осмотре оториноларинголога, при обращении и при госпитализации.

Диагностические признаки по стадиям

1. В стадии острого катарального воспаления барабанная перепонка гиперемирована, утолщена, опознавательные знаки определяются с трудом или не определяются.
2. В стадии острого гнойного воспаления боль в ухе резко усиливается, температура тела достигает фебрильных значений; барабанная перепонка ярко гиперемирована, выбухает, опознавательные знаки не определяются, возможна перфорация.
3. В постперфоративной стадии через перфорацию барабанной перепонки в наружный слуховой проход поступает гнойное отделяемое.
4. В репаративной стадии жалобы практически отсутствуют, цвет и толщина барабанной перепонки восстанавливаются, перфорация в большинстве случаев закрывается рубцом, однако восстановление слизистой оболочки среднего уха ещё не наступило.

3.3 Пневматическая отоскопия

Показания

1. острый средний отит при отсутствии реактивных изменений барабанной перепонки: определение её подвижности.

Диагностические признаки

1. снижение подвижности (податливости) барабанной перепонки указывает на воспалительный выпот в барабанной полости.

3.4 Тональная аудиометрия

Показания

1. затяжное течение (**более 10 дней**);
2. рецидивирующий отит;
3. исключение нейросенсорной тугоухости.

3.5 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. все пациенты с острым средним отитом.

Диагностические признаки

1. уровень лейкоцитоза позволяет оценить вероятность бактериальной природы воспаления (пороговые значения в таблице ниже).

3.6 Прокальцитонин крови

Показания

1. подозрение на тяжёлое течение;
2. сложные диагностические случаи: подтверждение бактериальной природы отита.

Маркеры бактериального воспаления

Показатель	Катаральный отит	Гнойный отит
Лейкоциты <10 / 10–15 / >15 ×10^9/л	50% / 38% / 12%	12% / 29% / 59%
СРБ <15 / 15–60 / ≥60 мг/л	33% / 50% / 17%	14% / 36% / 50%
ПКТ <0,5 / 0,5–2 / 2–10 нг/мл	58% / 38% / 4%	4% / 32% / 64%

Пороговые значения для гнойного отита

1. лейкоциты **>15×10^9/л** (ППР 85%, ПОР 64%);
2. С-реактивный белок (СРБ) **>30 мг/л** (ППР 79%, ПОР 52%);
3. прокальцитонин (ПКТ) **>2 нг/мл** (ППР 94%, ПОР 74%).

Таблица в PDF представлена изображением; значения перенесены вручную и сверены по изображению страницы 13.

3.7 Микробиологическое исследование отделяемого

Посев гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. парацентез или отделяемое из барабанной полости у пациентов в стационаре с тяжёлым и рецидивирующим течением.

Забор материала

1. отделяемое из барабанной полости забирают сухим стерильным ватным тампоном;
2. материал с соблюдением асептики помещают в пробирку с транспортной питательной средой;
3. оптимальное время доставки в лабораторию **40 минут**.

3.8 Компьютерная томография височных костей

Показания

1. затяжное течение (**более 10 дней**);
2. выраженная стойкая отрицательная динамика;
3. подозрение на мастоидит или внутричерепные осложнения.

Если КТ выполнить невозможно, по тем же показаниям проводят рентгенографию височных костей в проекциях по Шюллеру и Майеру.

4. Лечение

4.1 Обезболивающая и жаропонижающая терапия

При болевом синдроме и лихорадке применяют НПВП или парацетамол разово:

1. при боли в ухе;
2. при температуре тела **выше 38,5 °C**;
3. при фебрильных судорогах в анамнезе уже **при 38,0 °C**.

Детям **до 6 лет** допустимы только:

1. парацетамол: до 60 мг/кг в сутки, 10–15 мг/кг на приём;
2. ибупрофен: до 30 мг/кг в сутки, 8–10 мг/кг на приём.

Лекарственная форма у детей

1. дети раннего возраста: ректальные суппозитории или суспензия;
2. дети **старше 6 лет**: как правило, таблетки, покрытые плёночной оболочкой;
3. при невозможности приёма внутрь и ректального введения: парацетамол парентерально в разовой дозе 15 мг/кг.

У взрослых возможно применение кетопрофена; определённые фармакологические преимущества имеют препараты кетопрофена лизиновой соли.

Местное обезболивание обеспечивают ушные капли с лидокаином и феназоном; их применение допустимо только при отсутствии перфорации барабанной перепонки.

4.2 Показания к антибактериальной терапии

Системную антибактериальную терапию назначают при наличии хотя бы одного из показаний:

Показание	Пояснение
Возраст до 2 лет	Во всех случаях при наличии клинических признаков ОСО
Гнойная форма независимо от возраста	Перфорация барабанной перепонки с гнойным отделяемым; при отсутствии перфорации болевой синдром, не купируемый анальгетиками, в сочетании с выраженной гиперемией, отсутствием опознавательных знаков и выбуханием барабанной перепонки
Сохранение симптомов более 72 часов независимо от возраста	Боль, лихорадка или интоксикация при отоскопических признаках ОСО в течение 72 часов и более от начала заболевания
Рецидивирующее течение	3 и более эпизода за 6 месяцев или 4 и более за год
Сопутствующая патология	Сахарный диабет, иммунодефицитные состояния, муковисцидоз, синдромы цилиарной дискинезии, синдром Дауна, врождённые аномалии твёрдого и мягкого нёба
Невозможность повторного осмотра	Отсутствует возможность контрольного осмотра с отоскопией врачом-оториноларингологом или врачом общей практики

4.3 Выбор антибактериального препарата

Препаратом первой линии является амоксициллин при условии, что пациент не принимал его в течение последних 30 дней, а гнойный конъюнктивит и непереносимость аминопенициллинов отсутствуют.

Препаратами второй линии являются защищённые пенициллины и цефалоспорины III поколения. При отсутствии эффекта от амоксициллина **в течение 3 дней** его заменяют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим.

Причины неэффективности антибактериальной терапии

1. неадекватная дозировка антибиотика;
2. недостаточная всасываемость;
3. низкая приверженность лечению;
4. низкая концентрация препарата в очаге воспаления.

При затянувшемся и рецидивирующем отите стартовыми препаратами являются амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим внутрь.

При тяжёлом течении у пациентов стационара предпочтительно внутримышечное или внутривенное введение антибиотиков. Целесообразны цефалоспорины III поколения для парентерального введения: цефотаксим или цефтриаксон; при внутривенном введении возможно применение амоксициллина с клавулановой кислотой.

Макролиды у детей относятся к препаратам третьей линии; их применение оправдано только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов, поскольку устойчивость пневмококка к ним превышает 40%.

При лёгкой непереносимости пенициллинов альтернативой служат цефалоспорины III поколения: в амбулаторных условиях цефиксим, в стационаре при необходимости цефтриаксон парентерально.

Продолжительность курса составляет **7–10 дней**. Более длительные курсы необходимы:

1. детям до 2 лет;
2. пациентам с отореей;
3. пациентам с сопутствующими заболеваниями;
4. при затянувшемся и рецидивирующем отите: как правило, **не менее 14 дней**.

Антибактериальную терапию не прекращают до купирования отореи.

Тетрациклины, линкозамиды, аминогликозиды и ко-тримоксазол не рекомендуются в связи с низкой активностью в отношении пневмококка и гемофильной палочки и высокой частотой нежелательных явлений.

В постперфоративной стадии системная антибактериальная терапия продолжается.

4.4 Суточные дозы

Препарат	Взрослые	Дети
Препарат выбора		
Амоксициллин (независимо от приёма пищи)	0,5 г 3 раза в сутки без факторов риска[1]; 1,0 г 3 раза в сутки при факторах риска[2]	50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма[1]; 80–90 мг/кг в сутки при факторах риска[2] (по комментарию к рекомендации)
Альтернативные препараты		
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[3] (в начале приёма пищи)	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки	40–45 мг/кг в сутки в 2–3 приёма

Препарат	Взрослые	Дети
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в[4]	3,6 г в сутки в 3 введения	90 мг/кг в сутки в 3 введения (при массе тела 4–40 кг); 60 мг/кг в сутки (при массе тела менее 4 кг)
Ампициллин + сульбактам в/в[3]	1,5–3 г в сутки в 4 введения	150–300 мг/кг в сутки в 3–4 введения
Цефтриаксон[4]	2,0–4,0 г в сутки в 1 введение	50–80 мг/кг в сутки в 1 введение
Аллергия на пенициллины (не анафилактическая)		
Цефуроксим (непосредственно после приёма пищи)	500 мг в сутки в 2 приёма (так в таблице КР)	до 3 лет: 30 мг/кг в сутки в 2 приёма; старше 3 лет: 500 мг в сутки в 2 приёма
Цефиксим	400 мг в сутки в 1 приём	8 мг/кг в сутки в 1 приём
Аллергия на пенициллины и цефалоспорины		
Кларитромицин внутрь (показание «острый средний отит» зарегистрировано только для гранул для приготовления суспензии 125 и 250 мг/5 мл)	1000 мг в сутки в 2 приёма	15 мг/кг в сутки в 2 приёма

[1] Без факторов риска, [2] при факторах риска устойчивости пневмококка

1. приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца;
2. дети дошкольного возраста в семье, посещающие детские учреждения;
3. проживание в «закрытых» учреждениях.

[3] Факторы риска продукции β-лактамаз

1. сопутствующие заболевания (бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит);
2. иммуносупрессия;
3. неэффективность терапии амоксициллином.

[4] При высоком риске осложнений.

> В тексте рекомендации имеется расхождение. В комментарии к рекомендации об амоксициллине стандартная доза для детей составляет 45–60 мг/кг в сутки, а при высоком риске устойчивости пневмококка 80–90 мг/кг в сутки, тогда как в таблице 4 для детей указано 50–60 мг/кг в сутки.

У детей до 3 лет амоксициллин применяют только в форме суспензии или диспергируемых таблеток. Амоксициллин с клавулановой кислотой и цефиксим в таблетках и капсулах разрешены к применению с 12 лет; для детей младше 12 лет с массой тела менее 40 кг предназначены гранулы, порошок для приготовления суспензии или диспергируемые таблетки.

4.5 Местная и вспомогательная терапия

При перфорации барабанной перепонки купирование отореи ускоряют ушные капли на основе фторхинолонов или дексаметазона в комбинации с противомикробными средствами. Капли, содержащие аминогликозиды, и спиртосодержащие капли противопоказаны в связи с ототоксическим действием.

Возрастные ограничения ушных капель

1. норфлоксацин: **старше 1 года**;
2. ципрофлоксацин: **с 15 лет**;
3. офлоксацин, дексаметазон в комбинации с противомикробными средствами: **старше 1 года** при остром гнойном отите и установленной тимпаностомической трубке.

Сосудосуживающие капли в нос используют во всех стадиях для восстановления проходимости слуховой трубы на срок **не более 5–7 дней**. Применение нафазолина не рекомендуется.

Детям **до 6 лет**:

1. фенилэфрин 0,125%;
2. оксиметазолин 0,01–0,025%;
3. ксилометазолин 0,05%: с 2 лет.

До года допустимы только капли, после года по возможности переходят на дозированный назальный спрей.

Детям рекомендуется орошение полости носа изотоническим раствором морской воды 1–2 раза в день. У детей дошкольного возраста от промывания полости носа большими объёмами растворов следует воздержаться, поскольку это повышает риск развития отита.

Муколитические препараты применяют у детей старше 2 лет. Перед назначением следует свериться с зарегистрированными показаниями в инструкции, поскольку не каждый муколитик, эффективный при патологии бронхов, пригоден для лечения отита.

Формы муколитиков для детей

1. ацетилцистеин: детям старше 2 лет только раствор для приёма внутрь и гранулы для приготовления раствора;
2. карбоцистеин: детям до 15 лет только в форме сиропа.

4.6 Хирургическое лечение

Показания к парацентезу:

1. выраженная клиническая симптоматика и выбухание барабанной перепонки без перфорации;
2. болевой синдром, не купируемый НПВП;
3. отсутствие улучшения **через 48–72 часа** антибактериальной терапии.

Во всех сомнительных случаях решение принимают в пользу парацентеза.

Внутривисочные или внутричерепные осложнения требуют экстренной антромастоидотомии.

Парацентез на фоне системной антибактериальной терапии может рассматриваться как первая помощь при признаках внутривисочных и, в меньшей степени, внутричерепных осложнений: он позволяет выиграть время для подготовки к антромастоидотомии.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Через 3–4 недели необходим повторный осмотр оториноларингологом с пневмоотоскопией или тимпанометрией для исключения экссудативного среднего отита.

После стихания клинических проявлений пациенты наблюдаются у оториноларинголога, особенно дети с рецидивирующим или затянувшимся течением.

В постперфоративной стадии необходимо динамическое наблюдение до восстановления целостности барабанной перепонки и аэрации полостей среднего уха: отомикроскопия, тимпанометрия.

Жалобы на снижение слуха после перенесённого отита служат поводом для консультации сурдолога-оториноларинголога.

В репаративной стадии проводятся продувание слуховых труб и пневмомассаж барабанных перепонок. Восстановление аэрации подтверждается объективными методами, в том числе тимпанометрией.

Консультация физиотерапевта рекомендуется в репаративной стадии.

Всем детям показана вакцинация против пневмококковой инфекции в соответствии с национальным календарём профилактических прививок.

При рецидивирующем отите в плановом порядке выполняется шунтирование барабанной полости (тимпаностомия).

Показания к экстренной госпитализации:

1. тяжёлое течение;
2. отсутствие положительной динамики при лёгком течении на фоне адекватной терапии **в течение 3–5 дней**;
3. прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.

Пациента выписывают при стабильно удовлетворительном состоянии **не менее 3 дней**.

Более тяжёлое течение и высокий риск осложнений отмечаются у пациентов с иммунодефицитом и сахарным диабетом. Риск развития отита повышен у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), аллергическим ринитом, а также у курильщиков, в том числе пассивных.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Отит средний острый»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	314_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Детская доза амоксициллина в комментарии к рекомендации составляет 45–60 мг/кг/сут («стандартная») и 80–90 мг/кг/сут (при высоком риске устойчивости пневмококка), тогда как в таблице 4 указано 50–60 мг/кг/сут.
- Для цефуроксима у взрослых в таблице 4 указано «500 мг/сут в 2 приёма»; дозу следует сверить с инструкцией в ГРЛС.
- Ушные капли с норфлоксацином в данной рекомендации разрешены детям старше 1 года, в КР «Наружные отиты» (663_2) с 15 лет; возрастное ограничение следует сверить с инструкцией в ГРЛС.

Клинические рекомендации

Отосклероз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H80** — Отосклероз
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/315_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Клиническая картина:
  1. прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха;
  2. шум в ушах;
  3. при отомикроскопии барабанная перепонка не изменена.
- При тональной пороговой аудиометрии (всем пациентам) определяют:
  1. двустороннее повышение порогов воздушной проводимости на низких и средних частотах (**0,125–2 кГц**);
  2. чаще восходящую кривую;
  3. костно-воздушный интервал.
- При акустической импедансометрии выявляют:
  1. тимпанограмму типа А или As;
  2. отсутствие акустического рефлекса.
- Показания к стапедопластике:
  1. возраст **старше 15 лет**;
  2. кондуктивная или смешанная тугоухость;
  3. костно-воздушный интервал **не менее 25–30 дБ**;
  4. нет признаков активного отосклероза;
  5. нет общих противопоказаний.
- Всем пациентам выполняют МСКТ височных костей с денситометрией: плотность капсулы лабиринта **ниже 1000 HU** указывает на активный процесс.
- Инактивирующая терапия показана взрослым при:
  1. кохлеарной форме;
  2. активных очагах.
- Целью инактивирующей терапии является достижение плотности очагов **+1000…+1500 HU**; число курсов зависит от исходной плотности.
- Слуховые аппараты показаны при недостаточном уровне слуха и разборчивости речи в случаях:
  1. после операции;
  2. кохлеарная форма;
  3. противопоказания к операции или отказ от неё.
- Кохлеарная имплантация показана взрослым при двусторонней тугоухости 4–5 степени и разборчивости речи в слуховых аппаратах **менее 30%**.
- Госпитализация для стапедопластики плановая; выписка — **на 7–10-й день** после контрольной тональной аудиометрии.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Отосклероз: первичное метаболическое поражение костной капсулы ушного лабиринта, выражающееся особой формой остеодистрофии с преимущественно двусторонним очаговым поражением энхондрального слоя капсулы.

Вначале наблюдается резорбция кости с образованием мягких кровенаполненных отоспонгиозных очагов, затем в этих очагах откладываются соли кальция и формируется плотная склеротическая кость. Фазы размягчения и склерозирования имеют волнообразное течение.

2.2 Этиология

Отосклероз наследуется по аутосомно-доминантному типу; пенетрантность гена составляет 20–40%.

2.3 Аудиометрическая классификация

Классификация Н. А. Преображенского и О. К. Патякиной (1973): средние пороги костной проводимости (КП) на частотах **0,5, 1 и 2 кГц** по данным тональной пороговой аудиометрии (ТПА).

Форма	Средний порог КП (0,5–2 кГц)
Тимпанальная	до 20 (единица измерения в КР не указана)
Смешанная I	21–30 дБ
Смешанная II	более 30 дБ
Кохлеарная	более 50 дБ

> Границы форм в КР пересекаются: для смешанной формы II указано «>30 дБ» без верхней границы, для кохлеарной формы «КП >50 дБ». В таблице алгоритма обследования (приложение А3) для смешанной формы указаны пороги КП «до 50 дБ», при этом смешанные формы I и II не разделены.

2.4 Другие классификации

1. гистологический и клинический отосклероз;
2. активная (незрелая, отоспонгиоз) и неактивная (зрелая) стадии; тактика лечения во многом зависит от стадии.

Формы по распространённости очагов (мультиспиральная КТ, МСКТ)

1. фенестральная: очаги в области окна преддверия;
2. ретрофенестральная: очаги вокруг базального и апикального завитков улитки, в области окна улитки, полукружных каналов и дна внутреннего слухового прохода;
3. смешанная.

Очаги единичные и множественные.

Денситометрия капсулы лабиринта

1. норма: +2000…+2200 HU;
2. **ниже 1000 HU**: активный процесс (деминерализация, отоспонгиоз);
3. **выше 1000 HU**: неактивный.

По интраоперационной картине в нише окна преддверия стапедиальный отосклероз подразделяется на ограниченный, умеренный, распространённый и облитерирующий. Наиболее сложными для стапедопластики являются облитерирующие формы, которые подразделяются на три степени. При 1-й степени подножная пластина стремени равномерно утолщена очагами; при 2-й степени очаги сужают нишу окна преддверия по краям при неизменённой пластине; при 3-й степени очаги сужают нишу и захватывают как пластину, так и суперструктуры стремени.

2.5 Клиническая картина

Основные симптомы

1. прогрессирующее, чаще двустороннее снижение слуха;
2. шум в одном или обоих ушах: низко- и среднечастотный у половины пациентов, высокочастотный у 10%;
3. разборчивость речи в шуме лучше, чем в тишине (paracusis Willisii, паракузия Виллизия): примерно у половины;
4. головокружение и нарушение равновесия: лишь у 24%.

---

3. Диагностика

Критерии установления диагноза

1. жалобы на прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха и шум в ушах;
2. нормальная отомикроскопическая картина;
3. тональная аудиометрия: кондуктивная, смешанная или нейросенсорная тугоухость;
4. речевая аудиометрия: 100% разборчивость;
5. импедансометрия: тимпанограмма типа А или As, отсутствие акустических рефлексов.

Ультразвуковая аудиометрия и КТ височных костей

1. кохлеарная форма с односторонней или асимметричной тугоухостью: латерализация ультразвука в лучше слышащее ухо, пороги в норме или несколько выше;
2. фенестральная и смешанная формы: латерализация ультразвука в хуже слышащее ухо, пороги **до 15 дБ**;
3. КТ височных костей с денситометрией: участки пониженной плотности на фоне плотной однородной капсулы лабиринта;
4. фенестральная форма: очаг пониженной плотности в промонториальной стенке кпереди от окна преддверия;
5. кохлеарная форма: очаги повторяют ход завитков улитки и распространяются до стенок внутреннего слухового прохода.

> В критериях диагноза для смешанной формы указано, что ей свойственны признаки, «характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм». По смыслу, вероятно, имелась в виду кохлеарная форма.

Специфической лабораторной диагностики не существует. Лабораторные исследования выполняются при подготовке к плановой операции.

3.1 Жалобы и анамнез

У всех пациентов уточняют снижение слуха, шум в ушах, улучшение слуха в шуме и головокружение.

Снижение слуха

1. постепенное, без видимой причины;
2. как правило, двустороннее;
3. темп зависит от возраста начала (в «Подробнее»).

Односторонняя тугоухость встречается в 15–30% случаев. При раннем начале заболевания очаги чаще облитерирующие и распространённые, тугоухость быстро нарастает; при позднем начале очаги ограниченные, быстрого прогрессирования не наблюдается.

Шум в одном или обоих ушах.

Шум, как правило, низко- и среднечастотный (у 50%), реже высокочастотный (у 10%). В начале заболевания он ощущается только в тишине, по мере нарастания тугоухости усиливается.

Улучшение слуха в шумной обстановке.

Паракузия Виллизия встречается примерно у половины пациентов, чаще при выраженной фиксации стремени с сохранной костной проводимостью. При переходе тугоухости в смешанную форму этот симптом выявляется реже.

Головокружение и нарушения равновесия.

Эти жалобы предъявляют около 24% пациентов с отосклерозом. Их связывают с внутрилабиринтной гипертензией, поскольку после операции данные расстройства регрессируют.

3.2 Отомикроскопия

Отомикроскопию или отоэндоскопию выполняют всем пациентам.

Диагностические признаки

1. барабанная перепонка целостная, опознавательные знаки чёткие;
2. характерные признаки отосклероза выявляются лишь у части пациентов (в «Подробнее»).

Характерные признаки отосклероза при отомикроскопии выявляются лишь у 10–21% пациентов; их перечень приведён ниже.

К ним относятся симптом Лемперта (истончение барабанной перепонки с изменением её цвета вследствие атрофии фиброзного слоя), симптом Хилова (истончение кожи слухового прохода), симптом Тойнби (отсутствие или малое количество серы), симптом Швартца (просвечивание расширенных сосудов мыса через истончённую барабанную перепонку; является признаком активной стадии, встречается у 50%) и симптом Вирховского–Тилло (снижение чувствительности кожи слухового прохода и барабанной перепонки, снижение потоотделения, широкий слуховой проход). Ни один из этих симптомов не является патогномоничным, они оцениваются только в совокупности с другими проявлениями заболевания.

3.3 Камертональные пробы

Скрининговая оценка характера тугоухости у всех пациентов: пробы Ринне, Федеричи, Вебера.

Диагностические признаки

1. камертоны С128–С512: костно-воздушный интервал (пробы Ринне, Федеричи) и латерализация звука в хуже слышащее ухо (проба Вебера) — показание к тональной аудиометрии;
2. кохлеарная форма: пробы Ринне и Федеричи положительные, звук в пробе Вебера латерализуется в лучше слышащее ухо.

3.4 Тональная и речевая аудиометрия

Выполняется всем пациентам для определения формы и степени тугоухости.

Диагностические признаки

1. пороги воздушной (ВП) и костной проводимости, костно-воздушный интервал (КВИ, резерв улитки);
2. двустороннее повышение порогов ВП на **0,125–2 кГц**, чаще восходящая кривая с небольшим подъёмом;
3. по мере прогрессирования повышаются и пороги КП;
4. по типу кривой: тимпанальная, смешанная, кохлеарная форма.

Теория Р. Кархарта объясняет механическую природу сенсоневрального компонента нарушением микромеханики и гидродинамики улитки на частотах 0,5–2 кГц.

По данным речевой аудиометрии разборчивость речи составляет 100%.

3.5 Чувствительность к ультразвуку

Характер тугоухости у всех пациентов оценивают также по чувствительности к ультразвуку и его латерализации.

Диагностические признаки

1. пороги восприятия ультразвука **до 15 дБ**; при кохлеарной форме норма или незначительно повышены;
2. кохлеарная форма с односторонней или асимметричной тугоухостью: латерализация в лучше слышащее ухо;
3. латерализация в хуже слышащее ухо (60,9%) может свидетельствовать в том числе о гидропсе лабиринта; характерно при длительности заболевания **более 10 лет**, подтверждается экстратимпанальной электрокохлеографией (ЭКоГ).

Очаги могут вовлекать утрикулярный нерв и сдавливать эндолимфатический проток, а выраженная обструкция его дистального отдела может приводить к расширению саккулюса вплоть до контакта с основанием стремени. Однако ни одна методика не позволяет с полной уверенностью выявить гидропс лабиринта и установить его эндо- или перилимфатический характер, хотя это имеет значение для определения показаний к операции и её результата.

3.6 Акустическая импедансометрия

Тимпанометрию и акустическую рефлексометрию выполняют всем пациентам.

Цели

1. исключение патологии среднего уха;
2. оценка давления в среднем ухе, функции слуховой трубы, подвижности барабанной перепонки, состояния цепи слуховых косточек.

Диагностические признаки

1. тимпанограмма типа А или As;
2. отсутствие акустического рефлекса.

Акустическая импедансометрия является комплексным методом, включающим тимпанометрию, определение акустического импеданса (сопротивления) и акустического миорефлекса.

3.7 Данные аудиологического исследования при различных формах

Показатель	Тимпанальная	Смешанная	Кохлеарная
Тональная аудиометрия: вид кривой; пороги КП (0,5–2 кГц); КВИ	горизонтальная; до 20 дБ; 30–50 дБ	пологонисходящая; до 50 дБ; 30 дБ	крутонисходящая; выше 50 дБ; менее 10 дБ
Разборчивость речи	100%	100%	100%
Пороги чувствительности к ультразвуку (в КР единица «вт»)	10	10–15	более 15
Феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНГ)	не выявляется	редко	часто
Тимпанометрия	тип А	тип А	тип А
МСКТ височных костей	фенестральная локализация очагов	фенестральная и улитковая локализация очагов	часто деминерализация улитки

3.8 Мультиспиральная КТ височных костей с денситометрией

Выполняется всем пациентам: подтверждает диагноз, показывает локализацию и распространённость очагов, их активность.

МСКТ с шагом 0,3–1 мм в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией и денситометрией является единственным объективным неинвазивным методом решения этих задач; чувствительность метода составляет 80–95%, специфичность 99,1%.

До операции МСКТ выявляет состояния, имитирующие отосклеротическую тугоухость или снижающие эффективность операции

1. неотосклеротическая фиксация цепи слуховых косточек;
2. дегисценция верхнего полукружного канала;
3. расширение водопровода преддверия;
4. остеодистрофии (синдром Ван-дер-Хуве);
5. облитерирующий отосклероз;
6. оссификация окна улитки и лабиринта.

Снижение плотности капсулы лабиринта с нормальных +2000…+2200 до **+1500…+300 HU**: начальная или далеко зашедшая деминерализация.

Фенестральная форма

1. очаги чаще в области впередиоконной щели и переднего полюса основания стремени с переходом на переднюю ножку;
2. плотность зрелых очагов +1000…+1100 HU;
3. плотность **+500…+800 HU**: вероятен активный отосклероз (отоспонгиоз);
4. тугоухость от тимпанальной до смешанной формы.

При смешанной форме, помимо фенестральных очагов, определяются участки пониженной плотности капсулы вокруг улитки с переходом на область окна улитки, в ряде случаев до дна внутреннего слухового прохода. На аудиограмме при этом может регистрироваться смешанная тугоухость 1–2 степени.

При кохлеарном отосклерозе в начальной стадии в капсуле вокруг улитки определяются участки плотностью +1500…+1100 HU. В умеренно активной стадии вокруг базального и апикального завитков визуализируются отчётливые участки плотностью +1000…+600 HU, которые часто переходят на область окна улитки и могут распространяться до дна внутреннего слухового прохода и горизонтального полукружного канала.

В стадии высокой активности деминерализация распространяется на капсулу на уровне базального и апикального завитков, может достигать преддверия и полукружных каналов, плотность составляет +300…+600 HU. В этой стадии возможна костная облитерация структур лабиринта, чаще всего базального завитка и горизонтального полукружного канала.

> Плотность активных очагов в КР указана неодинаково: в тексте о фенестральной форме +500…+800 HU, в подписи к рисунку 1 +300…+800 HU. В подписи к рисунку 3 для кохлеарной формы указано +600…+800 HU, тогда как в тексте рядом приведены значения +1000…+600 HU для умеренной и +300…+600 HU для высокой активности.

МСКТ позволяет установить и причину неудачной стапедопластики: оценить положение протеза и глубину его погружения в преддверие, выявить некроз длинной ножки наковальни, перилимфатическую фистулу и гранулему окна преддверия.

---

4. Лечение

4.1 Инактивирующая терапия

Показания к инактивирующей терапии (взрослые)

1. кохлеарная форма;
2. тимпанальная и смешанная формы в активной стадии перед операцией;
3. активный отосклероз, выявленный во время операции.

Цель: инактивация очагов отоспонгиоза.

Эффекты

1. снижает активность отосклероза;
2. замедляет нарастание сенсоневрального компонента;
3. повышает плотность капсулы лабиринта;
4. уменьшает вероятность реоссификации после операции;
5. останавливает рост очагов и препятствует облитерации улитки.

Число курсов определяют по плотности очагов отоспонгиоза по данным МСКТ височных костей с денситометрией. Все препараты комплекса в КР отмечены знаком #, что обозначает применение вне инструкции.

4.2 Схема одного курса у взрослых

Препарат	Доза
#Ибандроновая кислота	Внутривенно болюсом за 15–30 секунд 3 мг/3 мл однократно в процедурном кабинете, 1 раз в 3 месяца, или внутрь 150 мг 1 раз в месяц за час до еды, запивая стаканом воды.
#Алендроновая кислота	Вместо ибандроновой кислоты: 70 мг 1 раз в неделю за час до еды, запивая стаканом воды.
#Кальция глюконат	500 мг 3 раза в день после еды.
#Натрия фторид	30–60 мг (0,5 мг/кг) **в течение 2 месяцев**.

Препарат	Доза
#Альфакальцидол	0,25 мкг 1 раз в день.

Курс **3 месяца**. По плотности очагов назначают 1, 2 или 4 курса с интервалами по 3 месяца до достижения плотности **+1000…+1500 HU**.

Плотность очагов по МСКТ	Число курсов
ниже +300 HU	4
+300…+600 HU	2
+600…+900 HU	1

> Активными в КР считаются очаги плотностью ниже 1000 HU, однако число курсов указано только для очагов до +900 HU: для очагов +900…+1000 HU схема не приведена.

4.3 Стапедопластика

Показания к стапедопластике

1. жалобы на снижение слуха и шум в ухе;
2. кондуктивная или смешанная тугоухость с КВИ **не менее 30 дБ**;
3. нет признаков активного отосклероза по отомикроскопии и МСКТ с денситометрией;
4. нет перфорации барабанной перепонки и инфекции слухового прохода;
5. нет общих противопоказаний к плановой операции.

Стапедопластика рекомендована пациентам **старше 15 лет**; в тексте рекомендации порог КВИ указан как **не менее 25–30 дБ**.

Операция является паллиативной. В пользу её выполнения свидетельствует то, что в неоперированных ушах нейросенсорный компонент нарастает в большей степени, чем в оперированных.

Противопоказания

1. острый воспалительный процесс, обострение хронического;
2. декомпенсация сопутствующих заболеваний.

Относительные противопоказания

1. активный отосклероз;
2. единственное слышащее ухо;
3. расширенный водопровод преддверия по МСКТ: описаны случаи глухоты после операции.

> Пороговое значение КВИ для операции в КР приведено трижды и неодинаково: в показаниях к хирургическому лечению (раздел 3.2) не менее 30 дБ, в тексте рекомендации 25–30 дБ, в показаниях к госпитализации (раздел 6) не менее 25 дБ.

Основание стремени вскрывают двумя способами: стапедотомия (методика малого окна, поршневая) или стапедэктомия (методика большого окна, частичная или тотальная). Протезы изготавливаются из алло- и аутотканей и биосовместимых материалов (тефлон, керамика, пластипор, сталь, титан, платина); сухожилие стременной мышцы и наковальне-стременное сочленение сохраняются или не сохраняются, окно преддверия изолируется аутотканью (вена, жир, клетчатка, фасция) или не изолируется.

Варианты выполнения операции

1. под местной анестезией или общим наркозом;
2. в стационаре или амбулаторно (хирургия одного дня);
3. с одной стороны или с двух сторон (симультантно);
4. трансканальным, эндауральным или заушным подходом, с микроскопом или эндоскопом.

При стапедотомии и частичной стапедэктомии операцию выполняют интрамеатальным подходом под местной анестезией по S. Rosen: 8,0 мл 2% раствора лидокаина с добавлением нескольких капель 0,1% раствора адреналина гидрохлорида (1:100000).

Средства ассистенции при стапедотомии

1. микробор (моторная система): сужение ниши окна преддверия очагами, толстое основание стремени, облитерирующие формы, длинный отросток наковальни над задним отделом основания;
2. CO2-лазер: неплотная фиксация стремени, тонкое основание, повышенная кровоточивость во время операции.

Размеры перфорации основания стремени и протеза

1. поршневая стапедопластика: перфорация 0,5–0,8 мм под протез диаметром 0,4–0,6 мм;
2. протез на аутовену: перфорация 0,8–1,0 мм, её закрывают венозным аутотрансплантатом с тыльной поверхности стопы;
3. заводские протезы: диаметр 0,4–0,6 мм, длина 4,25–4,5 мм.

Частичная стапедэктомия с удалением 2/3 основания стремени и протезом из аутохряща задней поверхности ушной раковины на венозном аутотрансплантате применяется только в России. Её преимущества: изоляция преддверия, исключение перилимфатических фистул и ампутации длинной ножки наковальни благодаря эластичности протеза, отсутствие затрат на протез.

Перфорацию основания 0,8–1,0 мм и более расширяют к заднему полюсу; аутохрящевой протез имеет высоту 3,5 мм и ширину в проксимальной части 0,8–1 мм.

Завершение операции

1. в барабанную полость вводят раствор дексаметазона;
2. при местной анестезии обязательно оценивают слух «живой» речью;
3. наружный слуховой проход рыхло тампонируют материалом с антибиотиком или антисептиком.

Наибольшее распространение в мире получила поршневая методика J. Shea (1962) ввиду минимальной травматичности для внутреннего уха и простоты выполнения; она обеспечивает КВИ не более 10 дБ у 58–98% пациентов.

Эффективны как стапедотомия, так и частичная стапедэктомия; при стапедэктомии сокращение КВИ в раннем послеоперационном периоде происходит быстрее. Сенсоневральная тугоухость после операции развивается у 3,5–5,9% пациентов, глухота у 0,9–2%.

Выбор методики учитывает

1. до операции: возраст, жалобы, анамнез, пороги КП и КВИ, строение височной кости по МСКТ;
2. во время операции: распространённость и активность очагов, строение ниши окна преддверия и канала лицевого нерва, кровоточивость тканей, давление перилимфы.

Показания к методикам стапедопластики

1. поршневая стапедопластика: молодой возраст (**до 40 лет**), активные очаги, узкая ниша окна преддверия, распространённые формы с крупными очагами на промонториуме, облитерирующие формы, выраженная кровоточивость;
2. аутотканевая стапедопластика: старший возраст, особенно при длительном снижении слуха; смешанные формы; расширенный водопровод улитки по МСКТ;
3. если аутотканевая стапедопластика невозможна: протез на аутовенозном трансплантате.

4.4 Выбор методики стапедопластики

Критерий	Поршневая	Протез на аутовену	Аутоткани
Молодой возраст (до 40 лет)	+	+	–
Длительность заболевания более 10 лет	–	–	+
Смешанная форма II	–	+	+
Активный отосклероз	+	+	–
Облитерирующий отосклероз	+	–	–
Анатомически узкая ниша окна преддверия	+	+	–
Гидропс лабиринта по данным ЭКоГ	+	+	+
Расширенный водопровод улитки, дегисценция верхнего полукружного канала и гидропс по данным ЭКоГ (перилимфатический гидропс)	–	+	+
Расширенный водопровод преддверия и гидропс по данным ЭКоГ (эндолимфатический гидропс)	–	в КР не заполнено	–

Чем больше диаметр отверстия в основании стремени и протеза при качественном выполнении операции, тем лучше гидродинамика лабиринта: пороги КП снижаются на 10–20 дБ по всей тон-шкале. При поршневой методике такой эффект не наблюдается.

4.5 Доля пациентов с КВИ не более 10 дБ после операции

Методика	10–12 дней	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
Аутотканевая	38%	78%	96%	96%	100%
Поршневая	20%	50%	56%	78%	76%

4.6 Кохлеарная имплантация и слухопротезирование

Кохлеарная имплантация показана взрослым с отосклерозом.

Показания

1. кохлеарная форма или высокие пороги после стапедопластики с двусторонней тугоухостью 4–5 степени;
2. разборчивость простых односложных слов со слуховыми аппаратами на оба уха **менее 30%**;
3. нет патологии улитки по МСКТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ);
4. достаточная мотивация.

Показания к слуховым аппаратам при недостаточном уровне слуха и разборчивости речи

1. после операции;
2. кохлеарная форма;
3. общие противопоказания к операции;
4. отказ от операции.

Уровень слуха ниже социального: пороги КП **более 30 дБ** или ВП **более 45 дБ** на речевых частотах (в разделе 4 КР: ВП 45 дБ и более).

При слухопротезировании учитывают

1. феномен ускоренного нарастания громкости (после операции и вне связи с ней);
2. желание пациента;
3. единственное слышащее ухо;
4. противопоказания к операции и отказ от неё.

---

5. Медицинская реабилитация. Показания к госпитализации и выписке

5.1 Медицинская реабилитация

Реабилитация состоит в слухопротезировании при уровне слуха ниже социального, в том числе после операции на единственном слышащем ухе; показания приведены выше, в разделе «Кохлеарная имплантация и слухопротезирование».

Методы профилактики отосклероза и диспансерного наблюдения в КР не приведены.

5.2 Организация медицинской помощи

Первичный осмотр пациента выполняют оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

Лечение и наблюдение пациентов с отосклерозом проводит сурдолог.

5.3 Показания к госпитализации

Показания к плановой госпитализации для операции

1. жалобы на снижение слуха и шум;
2. кондуктивная или смешанная тугоухость с КВИ **не менее 25 дБ**;
3. нет признаков активного отосклероза по отомикроскопии и МСКТ;
4. нет перфорации барабанной перепонки, инфекции слухового прохода, общих противопоказаний;
5. выполнено обследование для госпитализации.

5.4 Критерии выписки

Выписка **на 7–10-й день** после контрольной тональной аудиометрии, если:

1. пороги КП на дооперационном уровне;
2. КВИ в зависимости от методики прежний или сократился за счёт улучшения порогов ВП.

5.5 Послеоперационное ведение

Режим после операции

1. постельный режим **1–2 суток** на противоположном ухе (в зависимости от методики);
2. в течение **месяца** беречь ухо от воды и громких звуков;
3. в течение **3 месяцев** не летать на самолёте.

В информации для пациента указано, что операция даёт положительный результат у девяти из десяти пациентов и неэффективна менее чем у 1%.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Отосклероз»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «Пересмотр не позднее: 2026», следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	315_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В алгоритме действий врача (приложение Б) инактивирующая терапия стоит на ветви «Нет» вопроса «Есть кохлеарный отосклероз?», тогда как в разделе 3.1 она рекомендована именно при кохлеарной форме.
- Пороговое значение КВИ для стапедопластики указано трижды и неодинаково: 30 дБ (показания, раздел 3.2), 25–30 дБ (рекомендация), 25 дБ (показания к госпитализации, раздел 6).
- В классификации Преображенского–Патякиной границы смешанной формы II («>30 дБ») и кохлеарной формы («>50 дБ») пересекаются, для тимпанальной формы («до 20») не указана единица измерения; в таблице приложения А3 для смешанной формы указано «до 50 дБ».
- Пороги ультразвука в таблице приложения А3 приведены в ваттах, в тексте раздела 2.4 в децибелах.
- В тексте для отосклероза указана тимпанограмма типа «А» или «As», в таблице приложения А3 только тип А.
- В критериях диагноза для смешанной формы указано «признаки характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм», вероятно, вместо «кохлеарной».
- Плотность активных очагов по данным МСКТ в тексте и в подписях к рисункам 1 и 3 не совпадает.

- Число курсов инактивирующей терапии указано только для очагов до +900 HU, хотя активными считаются очаги плотностью ниже 1000 HU.

Клинические рекомендации

Паратонзиллярный абсцесс

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J36** — Перитонзиллярный абсцесс **J39.0** — Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс **J39.1** — Другой абсцесс глотки
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/664_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Лечение проводит оториноларинголог в стационаре; основным методом является хирургическое вскрытие абсцесса.
- Диагноз подтверждают фарингоскопические признаки:
  1. гиперемия, отёк и инфильтрация нёбных дужек, миндалин, мягкого нёба и язычка;
  2. асимметрия мягкого нёба и смещение миндалины;
  3. ограничение открывания рта (тризм).
- Антибактериальную терапию начинают эмпирически, не дожидаясь результатов посева, препаратами широкого спектра, активными в отношении анаэробов; курс **10–14 дней**.
- Показания к абсцесстонзиллэктомии (удалению миндалин одновременно со вскрытием абсцесса):
  1. частые ангины в анамнезе;
  2. повторный паратонзиллит или абсцесс;
  3. затяжное течение;
  4. неадекватное дренирование;
  5. кровотечение после вскрытия;
  6. прочие тонзиллогенные осложнения.
- Если выполнено только вскрытие: двусторонняя тонзиллэктомия в плановом порядке **через 3 месяца**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Паратонзиллярный абсцесс характеризуется гнойным расплавлением паратонзиллярной клетчатки, расположенной между псевдокапсулой нёбной миндалины и глоточной фасцией, покрывающей констрикторы глотки.

2.2 Этиология

Пути инфицирования

1. тонзиллогенный: в большинстве случаев как осложнение ангины, реже на фоне хронического тонзиллита;
2. одонтогенный: кариес задних зубов нижней челюсти (вторые моляры, зубы мудрости), периостит альвеолярного отростка;
3. попадание инородного тела (например, рыбной кости) в паратонзиллярную клетчатку.

Наиболее частыми возбудителями являются бета-гемолитический стрептококк группы А и неспорообразующие анаэробные микроорганизмы.

На момент обращения отёчная форма паратонзиллита встречается редко, инфильтративная форма выявляется у 15–20% пациентов, абсцедирующая форма у 80–85%. Абсцесс формируется, как правило, через 4–6 дней от начала заболевания, в ряде случаев в течение нескольких часов.

2.3 Локализация

1. передневерхний (супратонзиллярный): более 70%; между капсулой миндалины и верхней частью передней нёбной дужки;
2. задний: около 15%; между миндалиной и задней нёбной дужкой;
3. нижний: несколько более 5%; между нижним полюсом миндалины и боковой стенкой глотки;
4. боковой: менее 5%; между средней частью миндалины и боковой стенкой глотки.

2.4 Клиническая картина

Абсцесс развивается, как правило, на фоне ангины или через несколько дней после неё.

1. боль при глотании, постепенно становящаяся постоянной, резко усиливающаяся при глотании слюны, с иррадиацией в ухо и зубы;
2. головная боль, разбитость, повышение температуры тела до фебрильных значений; больные отказываются от пищи и питья;
3. нарастающий тризм жевательной мускулатуры;
4. невнятная, гнусавая речь;
5. боль при поворотах головы (вследствие воспаления мышц глотки и шейного лимфаденита): больной держит голову набок и поворачивает её вместе со всем корпусом.

Передневерхний абсцесс

1. резкое выбухание верхнего полюса миндалины вместе с нёбными дужками и мягким нёбом к средней линии;
2. язычок смещён в противоположную сторону;
3. миндалина оттеснена книзу и кзади.

Задний абсцесс

1. припухлость в области задней нёбной дужки, возможен переход на боковую стенку глотки;
2. миндалина и передняя дужка изменены незначительно;
3. отёк язычка и мягкого нёба.

Нижний абсцесс

1. фарингоскопические признаки выражены меньше всего (лишь отёк и инфильтрация нижней части передней дужки), хотя субъективные проявления значительны;
2. обычно вовлекается прилежащая часть корня языка, иногда развивается отёк язычной поверхности надгортанника;
3. коллатеральный отёк может распространиться на верхний отдел гортани и привести к её стенозу.

Боковой абсцесс

1. встречается реже остальных форм, но протекает тяжелее всех: гной развивается в клетчатке тонзиллярной ниши кнаружи от миндалины, поэтому условия для самопроизвольного прорыва в глотку наименее благоприятны;
2. выражены отёк и инфильтрация мягких тканей шеи на стороне поражения, кривошея, тризм;
3. со стороны глотки изменения меньше: умеренное выбухание всей миндалины и отёк окружающих тканей.

2.5 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. недавно перенесённые ангины;
2. хронический тонзиллит;
3. паратонзиллиты и абсцессы в прошлом и их лечение;
4. кариес;
5. возможное попадание инородного тела (рыбная кость).

Местные жалобы

1. выраженная, как правило односторонняя боль в горле, усиливающаяся при глотании, с иррадиацией в ухо и зубы;
2. ощущение инородного тела;
3. гнусавость;
4. неприятный запах изо рта;
5. боль в шее при поворотах головы;
6. тризм;
7. слюнотечение.

Общие жалобы (неспецифичны)

1. слабость, разбитость;
2. фебрильная лихорадка;
3. головная боль.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании:

1. анамнеза;
2. физикального обследования с оценкой подчелюстной области и регионарных лимфатических узлов;
3. фарингоскопии;
4. лабораторных исследований.

3.1 Осмотр и фарингоскопия

Показания

1. подозрение на паратонзиллярный абсцесс: осмотр оториноларинголога.

Фарингоскопия показана всем детям и взрослым; выявление фарингоскопических признаков является решающим в диагностике паратонзиллярного абсцесса.

Диагностические признаки (наиболее выражены при переднем абсцессе)

1. яркая гиперемия, отёк и инфильтрация нёбных дужек, миндалин, мягкого нёба и язычка;
2. асимметрия мягкого нёба;
3. смещение миндалины;
4. ограничение открывания рта;
5. регионарный лимфаденит.

3.2 Ларингоскопия

Показания

1. подозрение на распространение воспаления на гортаноглотку: непрямая ларингоскопия или фиброларингоскопия.

3.3 КТ и УЗИ шеи

Показания

1. уточнение диагноза и локализации абсцесса;
2. оценка состояния регионарных лимфатических узлов;
3. дифференциальная диагностика воспаления паратонзиллярной клетчатки и более глубоких отделов шеи.

КТ и УЗИ шеи применяют в тяжёлых случаях, когда точный диагноз или локализацию абсцесса установить не удаётся.

3.4 Анализы крови и мочи, посев

Всем пациентам: развёрнутый общий анализ крови, С-реактивный белок (СРБ), общий анализ мочи.

Диагностические признаки

1. высокий лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и высокий уровень СРБ свидетельствуют о высоком риске тонзиллогенных осложнений и требуют коррекции лечения, в том числе антибактериальной терапии.

Показания

1. гнойное отделяемое после вскрытия: посев на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности;
2. мазок с миндалин на палочку дифтерии: исключение дифтерии.

Для исследования предпочтительно брать не сам гной, а смыв или мазок со стенок полости, поскольку ферменты гноя разрушают микроорганизмы. Материал доставляется в лабораторию в транспортной среде, оптимально **в течение 40 минут**.

3.5 Дифференциальная диагностика

Дифференцируют также с абсцессами подъязычной области и перикоронитом.

При сходной односторонней припухлости ротоглотки (дифтерия, скарлатина) прежде всего учитывают эпидемиологические данные.

Заболевание	Отличия от паратонзиллярного абсцесса
Дифтерия	1. слизистая бледная, с цианотичным оттенком (отёк); 2. налёты сероватые, выходят за пределы миндалин; 3. тризма нет; 4. при микробиологическом исследовании выделяют токсигенные (tox+) штаммы Corynebacterium diphtheriae.
Скарлатина	1. розеолёзная сыпь на коже; 2. чёткая граница поражённой и интактной слизистой; 3. «малиновый» язык.
Абсцесс язычной миндалины	1. нет тризма; 2. нет характерных изменений в ротоглотке.
Флегмона дна полости рта	1. боль, отёк и инфильтрация в подчелюстной области; 2. движения языка ограничены; 3. нёбные дужки и миндалины не изменены.
Опухоли миндалины: рак, лимфосаркома, лимфоэпителиома	1. медленное развитие; 2. нет лихорадки, сильной боли в горле и тризма; 3. регионарные лимфатические узлы плотные, малоболезненные, малоподвижные.

Заболевание	Отличия от паратонзиллярного абсцесса
Поверхностное расположение сонной артерии или её аневризма (редко)	1. визуально определяемая пульсация.

4. Лечение

Лечение осуществляет оториноларинголог в специализированном учреждении; основным методом лечения является хирургическая санация полости абсцесса.

Иногда при своевременном адекватном консервативном лечении воспалительный процесс в паратонзиллярном пространстве подвергается обратному развитию; возможна также инкапсуляция небольшого абсцесса.

4.1 Хирургическое лечение

Впервые возникший абсцесс: вскрытие и дренирование.

Правила (при любой технике)

1. убедиться в отсутствии пульсации в месте разреза;
2. глубже **0,5 см** продвигаться только тупым путём;
3. разрез достаточно широкий, **до 4 см**.

Местная аппликационная анестезия; место разреза по локализации:

1. передневерхний: через переднюю нёбную дужку в типичном месте или в месте наибольшего выбухания;
2. задний: через заднюю дужку, отступив 0,5 см от её края;
3. нижний: в нижней части передней дужки.

Ткани рассекают вдоль хода сосудов на глубину 0,5–1 см, далее разводят корнцангом. После вскрытия проводятся полоскания глотки растворами антисептиков.

В последующем края разреза регулярно разводятся до начала заживления полости.

Абсцесстонзиллэктомия (удаление нёбных миндалин одновременно со вскрытием) устраняет и сам очаг инфекции. Показания:

1. частые ангины в анамнезе;
2. повторный паратонзиллит или абсцесс;
3. затяжное течение;
4. неадекватное дренирование;
5. кровотечение после вскрытия;
6. прочие тонзиллогенные осложнения.

Операцию проводят в любом возрасте: **от 3–4 до 70 лет и старше**.

Противопоказания

1. терминальное или крайне тяжёлое состояние вследствие заболеваний внутренних органов;
2. тромбоз сосудов мозга;
3. разлитой менингит.

После операции осматривают тонзиллярную нишу; выбухание в ней свидетельствует о парафарингеальном абсцессе.

4.2 Антибактериальная терапия

1. начинают эмпирически, не дожидаясь результатов посева;
2. в этиологии абсцесса велико значение микробных ассоциаций с участием облигатных анаэробов, поэтому необходимы препараты широкого спектра, активные и в отношении анаэробов.

Курс **10–14 дней**.

1. препараты выбора: пенициллины, в том числе с ингибиторами бета-лактамаз;
2. затруднённое глотание: диспергируемые формы, суспензии, инъекции;
3. выраженный отёк тканей глотки и шеи, выраженный тризм, высокий риск генерализации: парентеральные цефалоспорины III поколения, при непереносимости клиндамицин;
4. дети: предпочтительны ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой; доза зависит от возраста и массы тела.

Препарат	Режим дозирования
Пероральные антибактериальные препараты	
Амоксициллин и клавулановая кислота внутрь	1. взрослые и дети от 12 лет или с массой тела от 40 кг: 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки; 2. дети до 12 лет: 20–40 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
#Амоксициллин с сульбактамом внутрь	1. взрослые и дети от 12 лет: 1 г 2–3 раза в сутки; 2. длительность: **до 10 дней**.
Парентеральные антибактериальные препараты	
Цефтриаксон внутримышечно или внутривенно	1. взрослые: 2 г 1 раз в сутки; 2. новорождённые до 2 недель: 20–50 мг/кг 1 раз в сутки, не более 50 мг/кг в сутки; 3. дети от 15 дней до 12 лет: 20–80 мг/кг 1 раз в сутки; 4. длительность: в таблице рекомендации указана как «в течение 4–14 дней до 10 дней».
Цефотаксим внутримышечно или внутривенно	1. взрослые: 1 г 2 раза в сутки; 2. новорождённые и дети до 12 лет: 50–100 мг/кг в сутки с интервалом 6–12 часов; 3. недоношенные: не более 50 мг/кг в сутки; 4. длительность: **до 10 дней**.
Клиндамицин	1. взрослые: 300 мг 2 раза в сутки, при тяжёлом течении до 1,2–4,8 г в сутки в 2–4 приёма; 2. дети при непереносимости цефалоспоринов III поколения: #20–40 мг/кг в сутки в 3–4 приёма.

4.3 Дополнительная терапия

При выраженных воспалительных проявлениях используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в стандартных дозах.

Всем пациентам рекомендованы антигистаминные препараты системного действия.

Всем пациентам рекомендованы препараты системного действия, повышающие естественную резистентность организма (препараты кальция, витамины С и А); при их применении необходим динамический контроль, следует избегать полипрагмазии.

При выраженной интоксикации необходима инфузионная дезинтоксикационная терапия.

Всем пациентам дополнительно назначают местные противовоспалительные, обезболивающие и антисептические средства; они не заменяют системную антибактериальную терапию, поскольку не влияют на вероятность поздних аутоиммунных осложнений.

Лекарственные формы местных средств

1. полоскания;
2. инсуффляции;
3. ингаляции;
4. таблетки для рассасывания.

При назначении местных антисептиков соблюдают разрешённую кратность приёма и возрастные ограничения (некоторые из них токсичны), учитывают возможность аллергических реакций и индивидуальной непереносимости.

После хирургического лечения, не ранее чем через 3 недели после купирования острого воспаления, показана консультация физиотерапевта.

4.4 Послеоперационное ведение

После вскрытия абсцесса: двусторонняя тонзиллэктомия в плановом порядке **через 3 месяца**.

После тонзиллэктомии ограничение физической нагрузки **в течение месяца**.

---

5. Профилактика. Показания к госпитализации. Осложнения

1. при диспансеризации выявляют факторы риска: хронический тонзиллит, рецидивирующие ангины;
2. закаливание;
3. своевременное лечение заболеваний зубов и дёсен.

Лечение в хирургическом стационаре.

Показания к госпитализации

1. вскрытие абсцесса;
2. удаление нёбных миндалин со вскрытием абсцесса.

Улучшение состояния после вскрытия абсцесса наблюдается уже **через 12–24 часа**.

Критерии выписки

1. устойчивое купирование проявлений болезни и отсутствие угрозы жизни и здоровью пациента;
2. после удаления нёбных миндалин со вскрытием абсцесса при неосложнённом течении: **на 5–7-е сутки** после операции.

Осложнения при отсутствии или неадекватности лечения

1. флегмона шеи;
2. медиастинит;
3. тонзиллогенный сепсис;
4. инфекционно-токсический шок.

Риск выше при иммунодефиците: врождённом, на фоне иммуносупрессоров и цитостатиков, при ВИЧ-инфекции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Паратонзиллярный абсцесс»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	664_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для цефтриаксона в таблице 1 указано «в течение 4-14 дней до 10 дней», что содержит противоречие в сроках; на странице формулировка приведена дословно.

Клинические рекомендации

Парезы и параличи гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J38.0** — Паралич голосовых складок и гортани
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 07.10.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/305_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Парез гортани: нарушение подвижности мышц гортани из-за нарушения иннервации **до 6 месяцев**; паралич — **более 6 месяцев**. Чаще всего возникает после операций на щитовидной железе.
- Диагноз устанавливается по данным ларингоскопии: голосовая складка неподвижна или резко ограничена в подвижности. Для поиска причины выполняют КТ шеи и грудной клетки, УЗИ гортани и шеи, направляют к эндокринологу и неврологу.
- При одностороннем поражении как можно раньше начинают логопедическую коррекцию голоса, у взрослых в ранние сроки добавляют антихолинэстеразные препараты и витамины группы В; реконструктивную операцию выполняют **после 6 месяцев**. При двустороннем поражении с декомпенсацией дыхания показана трахеотомия или хордопексия.
- Срочная госпитализация показана при паралитическом стенозе гортани в стадии субкомпенсации и декомпенсации, плановая — для операции.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

1. парез гортани: временное, **до 6 месяцев**, отсутствие или ограничение подвижности мышц гортани вследствие нарушения иннервации;
2. паралич гортани: длительное, **более 6 месяцев**, отсутствие подвижности мышц гортани.

2.2 Этиология

Односторонний паралич: причины

1. операции на щитовидной и околощитовидных железах;
2. операции при атеросклерозе сонных артерий, раке лёгкого, врождённых пороках сердца;
3. новообразования со сдавлением возвратного нерва: рак щитовидной железы, лёгкого, пищевода, метастазы в лимфатические узлы средостения;
4. операции на шейном отделе позвоночника, травма, опухоли головного мозга, инсульт, демиелинизирующая нейропатия;
5. перенесённая ОРИ, туберкулёз лёгких;
6. причина не установлена (идиопатический паралич).

Частота причин одностороннего паралича

1. операции на щитовидной и околощитовидных железах: 72,4%;
2. операции при атеросклерозе сонных артерий, раке лёгкого, врождённых пороках сердца: 7,2%;
3. новообразования: 6,8%;
4. операции на шейном отделе позвоночника, травма, опухоли мозга, инсульт, демиелинизирующая нейропатия: 5,7%;
5. перенесённая ОРИ, туберкулёз лёгких: 4,5%;
6. идиопатический: 3,4%.

Двусторонний паралич: причины

1. хирургическая травма;
2. злокачественные новообразования;
3. эндотрахеальная интубация;
4. неврологические заболевания;
5. причина неизвестна.

Частота причин двустороннего паралича

1. хирургическая травма: 44%;
2. злокачественные новообразования: 17%;
3. эндотрахеальная интубация: 15%;
4. неврологические заболевания: 12%;
5. причина неизвестна: 12%.

Центральные параличи (10%): надъядерные (кортикальные, кортикобульбарные) и бульбарные — при нарушении мозгового кровообращения, опухолях, черепно-мозговой травме, менингоэнцефалите, полиомиелите, ДЦП, рассеянном склерозе, после операций на мозге. Функциональные центральные параличи возникают при нервно-психических расстройствах, чаще при истерии.

Односторонний паралич у детей

1. новообразования;
2. послеоперационные осложнения;
3. воспалительные процессы;
4. постинтубационная и наружная травма;
5. центральные и идиопатические параличи.

Закрытие артериального (боталлова) протока у новорождённых массой **менее 1000 г** часто даёт паралич левого возвратного нерва: стридор, осиплость, трудности кормления, аспирация.

Частота причин одностороннего паралича у детей

1. новообразования: 29%;
2. послеоперационные осложнения: 24%;
3. воспалительные процессы: 21%;
4. постинтубационная и наружная травма: 8%;
5. центральные: 5%, идиопатические: 13%.

Повреждение возвратного нерва при кардиохирургических вмешательствах: до 4%.

2.3 Классификация

1. по уровню поражения блуждающего нерва: центральные, периферические;
2. по этиологии: врождённые, приобретённые;
3. по распространённости: односторонние, двусторонние.

2.4 Клиническая картина

Страдают все функции гортани: разделительная (защитная), голосовая (охриплость), дыхательная (стеноз или гипервентиляция). Картина зависит прежде всего от положения парализованной складки.

Положение складки у взрослых

1. срединное;
2. парамедианное: 2 мм от срединной линии;
3. интермедианное: 4 мм;
4. латеральное: максимальное отведение на глубоком вдохе.

Проявления по положению голосовых складок

Поражение	Положение складки	Проявления
Одностороннее	медианное, парамедианное	дисфония небольшая; одышка только при нагрузке или избыточной массе; дисфагии нет
Одностороннее	интермедианное, латеральное	дисфония вплоть до афонии; одышки при нагрузке нет, но гипервентиляция; трудно откашляться, поперхивание; латеральное — при полном поражении блуждающего нерва
Двустороннее	латеральное	нарушение разделительной функции, афония, невозможность откашляться, гипервентиляция (головокружение при нагрузке и разговоре)
Двустороннее	интермедианное, парамедианное, медианное	на первый план — дыхательная недостаточность; голос может быть звучным, разделительная функция сохранена

Стадии паралитического стеноза гортани

Стадия стеноза	Голосовая щель у взрослых	Признаки
Компенсация	6–8 мм	одышки в покое нет, появляется при ходьбе
Субкомпенсация	3–4 мм	инспираторная одышка, при нагрузке — вспомогательные мышцы, втяжение межрёберий и ямок, стридор, бледность; давление нормальное или повышено
Декомпенсация	2–3 мм	частое поверхностное дыхание, резкий стридор, вынужденное положение сидя, бледно-синюшное лицо, потливость, акроцианоз, нитевидный пульс, давление снижено
Асфиксия	1 мм	дыхание Чейна — Стокса или остановка, угнетение сердечной деятельности, потеря сознания, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, остановка сердца

Неплотное смыкание складок и ротация черпаловидного хряща ведут к аспирации (поперхиванию); одышка усиливается при голосовой нагрузке.

Последствия аспирации

1. ларингит;
2. трахеит;
3. аспирационная пневмония.

На состояние влияют

1. сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания;
2. эндокринные: гипотиреоз, гипопаратиреоз;
3. деформация шейного и грудного отделов позвоночника.

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. анамнез: травма или операция на шее, органах средостения, шейном отделе позвоночника, головном мозге; инфекционные заболевания;
2. жалобы: дисфония, афония, дисфагия, одышка;
3. осмотр и пальпация гортани, оценка дыхания, признаки стеноза;
4. непрямая ларингоскопия, фиброларингоскопия, видеоларингоскопия, микроларингоскопия.

3.1 Жалобы и анамнез

Типичные жалобы

1. одностороннее поражение: утомляемость голоса, придыхание, одышка при нагрузке, аспирация жидкостью; возможна дисфагия;
2. двустороннее: нарушение дыхания, инспираторный стридор при нагрузке, во сне, при разговоре.

Ларингоспазм может быть следствием синкинезии — неправильной реиннервации, когда на вдохе сокращаются суживающие мышцы; а также рефлюкса, гипокальциемии, аллергии, неврологических и психических расстройств.

Дыхательные нарушения при истерии проявляются шумным стридорозным дыханием днём в присутствии посторонних; дыхание становится свободнее, когда пациент отвлекается, и спокойным во сне. Трахеотомия противопоказана, лечение проводят в психоневрологическом стационаре.

У детей

1. односторонний паралич: осиплость — 100% (в первый месяц может быть афония), затем аспирация при кормлении, стридор — около 36%;
2. двусторонний: инспираторный или двухфазный высокотональный стридор — 100%, усиливается при нагрузке, в 30% исчезает во сне; стеноз I–III степени.

3.2 Осмотр врача-оториноларинголога

Всем пациентам с подозрением на паралич гортани: осмотр оториноларинголога, пальпация шеи и регионарных лимфоузлов для выявления воспаления, опухоли, травмы.

Степени дыхательной недостаточности

1. I степень: одышка при умеренной нагрузке;
2. II: при малой нагрузке;
3. III: в покое.

Оценивают также рубцы на шее (сращение кожи с трахеей нарушает подвижность гортани) и неврологические признаки: асимметрию нёба, языка, фасцикуляции языка.

Признаки декомпенсации дыхания

1. общее состояние тяжёлое: слабость, апатия или крайнее беспокойство;
2. цианоз пальцев рук и лица;
3. одышка в покое и при небольшой физической нагрузке, шумное дыхание, озвученный вдох (инспираторная одышка), учащение дыхания;
4. участие вспомогательной мускулатуры в дыхании;
5. тахикардия, повышение артериального давления.

3.3 Общий анализ крови

Показания

1. подозрение на острое воспаление ЛОР-органов: развёрнутый общий (клинический) анализ крови.

3.4 Ларингоскопия

Всем с подозрением на парез или паралич: эндоскопическая ларингоскопия — микроларингоскопия, стробоскопия, видео- и фиброларингоскопия.

Непрямая ларингоскопия обязательна с **12 лет**; у дошкольников и младших школьников — видеофиброларингоскопия или фиброларингоскопия («золотой стандарт» у детей).

Диагностические признаки

1. неподвижность или резкое ограничение подвижности одной или обеих складок, черпаловидный хрящ ограниченно подвижен или неподвижен;
2. при фонации щель между складками: овальная, линейная, треугольная; здоровая складка может заходить за среднюю линию;
3. парализованная складка укорочена, атрофична: вогнутый серповидный край, истончение, выступающий голосовой отросток, складка ниже здоровой;
4. черпаловидный хрящ наклонён вперёд, ротирован медиально.

Дифференцируют

1. перихондрит (артрит) перстнечерпаловидного сустава: отёк, инфильтрация, гиперемия;
2. анкилоз: хрящ полностью неподвижен;
3. вывих: асимметрия суставов, воспаление, нетипичное положение хряща;
4. новообразования, ведущие к неподвижности складки.

Гипертрофия вестибулярных складок носит компенсаторный характер и операции не требует.

У плачущего ребёнка складки сомкнуты, что имитирует двусторонний паралич, поэтому следует дождаться адекватного вдоха с разведением складок, которого при двустороннем параличе не будет.

3.5 Лучевые методы исследования

Показания: все пациенты с парезом или параличом гортани

1. КТ верхних дыхательных путей и шеи; при недоступности КТ — рентгенография гортани или шейного отдела позвоночника в двух проекциях;
2. КТ органов грудной полости: поиск объёмных образований;
3. УЗИ гортани и лимфатических узлов шеи: поиск объёмных образований.

При подозрении на новообразование

1. КТ верхних дыхательных путей и шеи с контрастным усилением.

3.6 Консультации специалистов

Для поиска причины и выбора лечения показаны консультации эндокринолога и невролога; при подозрении на другие причины — пульмонолога, гастроэнтеролога, онколога.

4. Лечение

4.1 Медикаментозное лечение

Проводят лечение основного заболевания в сочетании с антихолинэстеразными препаратами, стимулирующими нервно-мышечную передачу. Детям **до 18 лет** препараты противопоказаны.

Взрослые

1. #неостигмина метилсульфат в ранние сроки: внутрь 0,015 г 2 раза в день или 1 мл 0,05% раствора подкожно 1–2 раза в день, 2 недели;
2. #ипидакрин при одностороннем параличе: в/м 1 мл (15 мг) 1 раз в день 10 дней, затем 20 мг внутрь 3 раза в день (в КР «45 дней месяца»).

#Ипидакрин назначают взрослым с односторонним параличом для восстановления подвижности парализованной складки.

Взрослым в ранние сроки назначают витамин В1 в комбинации с В6 и (или) В12. Следует учитывать противопоказания при онкологических заболеваниях; детям **до 18 лет** не назначают.

4.2 Логопедическая коррекция, физиотерапия и реабилитация

Показания

1. взрослые и дети с односторонним параличом: индивидуальная программа логопедической коррекции в самые ранние сроки, до окончания обследования и медикаментозного лечения;
2. все пациенты с параличом гортани, в том числе после операции: программа логопедической реабилитации.

Здоровая складка компенсаторно заходит за среднюю линию и смыкается с неподвижной. Три этапа; на каждом — дыхание, тонус и подвижность гортани, высота, сила и тембр голоса. Начинают при отсутствии боли в ране и острого воспаления.

Реабилитацию (логопедическая коррекция, физиотерапия) начинают с первого обращения, при параличе после операции или инсульта — **не позднее 72 часов** после установления диагноза, по возможности с участием мультидисциплинарной команды; амбулаторно или в дневном стационаре фониатрического центра.

Всем пациентам показана консультация физиотерапевта для улучшения трофики и нервно-мышечной передачи.

4.3 Хирургическое лечение у взрослых

Операции у взрослых

Ситуация	Операция
двусторонний паралич, декомпенсация дыхания	трахеотомия
двусторонний паралич, декомпенсация, до 6 месяцев от поражения	временная хордопексия (латерофиксация складки)
двусторонний паралич, более 6 месяцев	двусторонняя хордопексия

Ситуация	Операция
двусторонний паралич, дыхание через естественные пути невозможно, консервативное лечение неэффективно более 6 месяцев	микроэндоларингеальная резекция с эндоскопическими и лазерными технологиями, пластика гортани
двусторонний и односторонний паралич	реиннервация и функциональная пластика гортани и трахеи микрохирургически
односторонний паралич, более 6 месяцев	эндоларингеальное реконструктивное вмешательство на складках с имплантами — восстановление голоса

Пластика и резекция гортани не показаны при двустороннем параличе из-за неоперабельных опухолей щитовидной железы, лёгких, пищевода, метастазов в средостение: при декомпенсации — трахеотомия.

4.4 Хирургическое лечение у детей

Операции у детей

Ситуация	Операция
врождённый и приобретённый двусторонний паралич, декомпенсация дыхания	трахеотомия
дети старше 4 лет, двусторонний паралич, субкомпенсация, трахеостомы нет	хордаритеноидотомия эндоскопически
дети старше 4 лет, приобретённый двусторонний паралич, есть трахеостома	хордаритеноидотомия и контрлатеральная **через 6 месяцев** — для деканюляции
дети старше 4 лет, двусторонний паралич (в том числе приобретённый), есть трахеостома	пластика гортани с рёберным аутотрансплантатом в заднюю стенку
дети старше 5 лет, врождённый двусторонний паралич без признаков восстановления, есть трахеостома	пластика гортани с рёберным аутотрансплантатом в заднюю стенку
дети старшего возраста, двусторонний и односторонний паралич	реиннервация и функциональная пластика

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания

1. срочная: острый и хронический паралитический стеноз гортани в стадии субкомпенсации и декомпенсации;
2. плановая: хирургическое лечение одно- или двустороннего паралича.

Выписка

1. после срочной госпитализации: восстановлено дыхание, нет дыхательной недостаточности;
2. после операции при двустороннем параличе: улучшено дыхание через естественные пути, стихли послеоперационные явления;
3. при одностороннем: улучшен голос.

5.2 Диспансерное наблюдение

Диспансерный осмотр оториноларинголога (фониатра) с ларингоскопией **раз в 3 или 6 месяцев** — в зависимости от дыхательной недостаточности.

5.3 Редкие синдромы с парезом гортани

Редкие синдромы

Синдром	Поражение и проявления
Тапиа	двойное ядро (IX, X), ядра XI, XII и пирамидные пути: парез глотки, мягкого нёба, гортани, грудино-ключично-сосцевидной мышцы, языка, контралатеральный гемипарез; осложнение масочной вентиляции, интубации, бронхоскопии
Коле — Сикара	IX–XII нервы: охриплость, дисфагия, боль в глотке, нарушение вкуса задней трети языка; опухоли яремного отверстия, травма, аневризма, метастазы
Вернета	IX–XI: паралич нёба, гортани, глотки, грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц; огнестрельные ранения, переломы основания черепа, тромбоз яремной вены
Вилларе	IX–XII, симпатический нерв, волокна VII: дисфагия на твёрдую пищу, паралич нёба и гортани с одной стороны
Авеллиса	IX–XII: дисфагия, дисфония, дизартрия, гемигипестезия противоположных конечностей, опущение плеча

Односторонний паралич гортани может сопровождать боковой амиотрофический склероз, невралгическую амиотрофию (синдром Персонейджа — Тернера), множественную системную атрофию, травмы, опухоли, инсульт.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Парезы и параличи гортани»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 07.10.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2029 года
Код в рубрикаторе	`305_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность приёма #ипидакрина в таблетках записана как «45 дней месяца» — неясно, 45 дней или иной срок. Сверяйте с инструкцией препарата.

Клинические рекомендации

Первичные иммунодефициты с недостаточностью синтеза антител

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D80.0** — Наследственная гипогаммаглобулинемия **D80.1** — Несемейная гипогаммаглобулинемия **D80.2** — Избирательный дефицит иммуноглобулина A [IgA] **D80.3** — Избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G [IgG] **D80.4** — Избирательный дефицит иммуноглобулина M [IgM] **D80.5** — Иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина M [IgM] **D80.6** — Недостаточность антител с близким к норме уровнем иммуно глобулинов или с гипериммуноглобулинемией **D80.7** — Преходящая гипогаммаглобулинемия детей **D80.8** — Другие иммунодефициты с преимущественным дефектом антител **D80.9** — Иммунодефицит с преимущественным дефектом антител неуточненный **D83.0** — Общий вариабельный иммунодефицит с преобладающими отклонениями в количестве и функциональной активности B-клеток **D83.1** — Общий вариабельный иммунодефицит с преобладанием нарушений иммунорегуляторных T-клеток **D83.2** — Общий вариабельный иммунодефицит с аутоантителами к B- или T-клеткам **D83.8** — Другие общие вариабельные иммунодефициты **D83.9** — Общий вариабельный иммунодефицит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.05.2022, пересмотр не позднее 2024 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Национальная Ассоциация Экспертов в области Первичных Иммунодефицитов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/735_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Первичные иммунодефициты (ПИД) с преимущественной недостаточностью синтеза антител представляют собой генетически обусловленные заболевания с нарушением образования антител в ответ на инфекцию или вакцинацию. Это самая частая группа ПИД.
- Общим признаком являются рецидивирующие инфекции синопульмонального тракта, торпидные к стандартной антибиотикотерапии, с повышенной восприимчивостью к инкапсулированным бактериям.
- Тяжёлые хронические или рецидивирующие синуситы и отиты, торпидные к стандартной терапии, служат показанием к скринингу на ПИД. Для верификации определяют IgA, IgG, IgM в крови.
- Гипогаммаглобулинемией считается IgG ниже 2 стандартных отклонений от возрастной нормы у детей и **ниже 4,5 г/л** у взрослых. Изменения подтверждают как минимум двумя исследованиями.
- При агаммаглобулинемии, общей вариабельной иммунной недостаточности (ОВИН) и гипер-IgM-синдроме регулярную заместительную терапию иммуноглобулином человека нормальным начинают незамедлительно после установления диагноза. Целевой претрансфузионный IgG **не ниже 7 г/л**.
- При ОВИН, агаммаглобулинемии и гипер-IgM-синдроме живые вакцины не рекомендуются.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Первичные иммунодефициты (ПИД) — группа врождённых заболеваний иммунной системы, насчитывающая более 450 нозологий, связанных с утратой, уменьшением или неправильным функционированием одного или нескольких её звеньев.

Гипогаммаглобулинемия — снижение уровня IgG в крови ниже 2 стандартных отклонений от возрастной нормы у детей и ниже 4,5 г/л у взрослых.

Агаммаглобулинемия — снижение уровня IgG ниже 1,0 г/л в сочетании с IgM ниже 0,2 г/л и IgA ниже 0,1 г/л при уровне периферических CD19+ B-клеток ниже 2%.

Претрансфузионный уровень IgG — уровень IgG, исследованный в день перед введением иммуноглобулина человека нормального (наиболее низкий его показатель в течение месяца).

ПИД с преимущественным нарушением синтеза антител — генетически детерминированные заболевания с нарушением антителообразования в ответ на инфекцию или вакцинацию: от снижения всех классов иммуноглобулинов и отсутствия B-лимфоцитов до селективного дефицита антител.

Основные формы

1. общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН);
2. X-сцепленная агаммаглобулинемия (болезнь Брутона) и аутосомно-рецессивные агаммаглобулинемии;
3. селективный дефицит IgA;
4. дефицит подклассов IgG;
5. нарушение синтеза специфических антител;
6. транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия.

2.2 Этиология и эпидемиология

В основе лежит нарушение дифференцировки В-лимфоцитов в костном мозге или в периферических лимфоидных органах. Около 90% наследственных агаммаглобулинемий составляет болезнь Брутона (ген Btk на Х-хромосоме), поэтому болеют лица мужского пола. Генетическую основу ОВИН в большинстве случаев установить не удаётся.

ПИД с нарушением синтеза антител составляют более 50% всех ПИД. Распространённость ОВИН — от 1:10 000 до 1:50 000, агаммаглобулинемии — от 1:100 000 до 1:200 000, селективного дефицита IgA — от 1:142 до 1:18 000 (у большинства бессимптомно).

2.3 Клиническая картина

Объединяющий признак — рецидивирующие инфекции преимущественно синопульмонального тракта с повышенной восприимчивостью к инкапсулированным бактериям. Характерна торпидность к стандартным схемам антибиотикотерапии при отсутствии предрасполагающих факторов.

Тяжёлые повторные инфекции приводят к бронхоэктазам и пневмосклерозу. На втором месте после синопульмональных — инфекционные поражения ЖКТ.

Х-сцепленная агаммаглобулинемия (болезнь Брутона)

1. дебют, как правило, **от 6 месяцев до 1 года**, после истощения материнских антител;
2. гипоплазия миндалин и лимфатических узлов;
3. хронические синуситы с частыми обострениями;
4. бронхоэктазы после повторных пневмоний;
5. нейросенсорная тугоухость как следствие перенесённых гнойных средних отитов;
6. деформации суставов после артритов;
7. нейтропения в дебюте;
8. отставание в физическом развитии.

Общая вариабельная иммунная недостаточность

1. два пика дебюта: 2–5 лет и 18–25 лет;
2. инфекции, сходные с болезнью Брутона;
3. лимфопролиферация: лимфаденопатия (около 40%), спленомегалия (до 60%), гепатомегалия (до 15%).

Одно из самых тяжёлых неинфекционных осложнений ОВИН — интерстициальная болезнь лёгких; характерны неказеозные саркоидоподобные гранулёмы в лёгких, лимфоузлах, селезёнке.

Другие неинфекционные проявления ОВИН

1. поражение ЖКТ: диарея более чем у 20%, мальабсорбция; целиакия- и кроно-подобное поражение, НЯК, нодулярная лимфоидная гиперплазия;
2. иммунные цитопении (10–29%), нередко первый симптом;
3. повышенный риск злокачественных новообразований, особенно неходжкинских лимфом.

Селективный дефицит IgA у двух третей пациентов протекает бессимптомно; при симптомах характерны не столько тяжёлые, сколько частые инфекции, а также заболевания ЖКТ, аутоиммунные и аллергические болезни. Тяжелее течёт сочетание с дефицитом подклассов IgG.

При дефиците подклассов IgG и специфических антител более характерны синуситы, отиты, бронхиты; пневмонии и менингиты встречаются реже, отмечается склонность к аллергическим заболеваниям.

Транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия — удлинение физиологического периода гипогаммаглобулинемии (обычно **до 3–6 месяцев**); может протекать бессимптомно или с частыми инфекциями верхних и нижних дыхательных путей.

Дифференциальная диагностика с саркоидозом по КТ: при ОВИН чаще поражаются нижние доли, узелки крупные, расположены хаотично, характерны бронхоэктазы; при саркоидозе узелки мелкие, перилимфатические, с лимфаденопатией корней лёгких, бронхоэктазов, как правило, нет.

3. Диагностика

3.1 Диагностические критерии ESID

Диагностические критерии ESID форм ПИД с недостаточностью синтеза антител

Форма ПИД	Критерии
ОВИН	1. ≥1 признак: подверженность инфекциям, аутоиммунные проявления, гранулёмы, необъяснимая лимфопролиферация, ПИД у членов семьи; 2. выраженное снижение IgG (в 2 исследованиях на 2 SD от возрастной нормы, у взрослых менее 4,5 г/л) и IgA, с IgM или без; 3. неадекватный ответ на вакцинацию (или отсутствие изогемагглютининов) либо переключённых B-клеток памяти менее 70% от возрастной нормы; 4. вторичная гипогаммаглобулинемия исключена; 5. возраст старше 4 лет; 6. нет глубокого нарушения Т-клеточного звена.
Х-сцепленная агаммаглобулинемия	1. окончательный диагноз: мужчина с CD19+ B-клетками менее 2% и мутацией в гене Btk (или отсутствием мРНК либо экспрессии Btk, или родственниками по материнской линии с CD19+ менее 2%); 2. вероятный: CD19+ менее 2% и все признаки — инфекции до 5 лет, снижение IgG, IgM, IgA более чем на 2 SD, нет изогемагглютининов или плохой ответ на вакцинацию, исключены другие причины; 3. возможный: CD19+ менее 2%, исключены другие причины и хотя бы один из этих признаков.
Гипер-IgM-синдром	1. ≥1 признак: подверженность инфекциям, иммунная дисрегуляция, цитопении, лимфома, ПИД у членов семьи; 2. выраженное снижение IgG при нормальном или повышенном IgM (в 2 исследованиях); 3. исключены другие причины и глубокое нарушение Т-клеточного звена, нет данных за атаксию-телеангиэктазию.
Нарушение синтеза специфических антител	1. рецидивирующие и тяжёлые бактериальные инфекции; 2. IgG, IgA, IgM и подклассы IgG в норме; 3. глубокое нарушение синтеза антител после полисахаридной вакцины или документированной инфекции; 4. Т-клеточный дефект исключён.
Дефицит подклассов IgG	1. рецидивирующие и тяжёлые бактериальные инфекции; 2. IgA, IgG, IgM в норме; 3. снижение одного или нескольких подклассов IgG при двукратном измерении; 4. поствакцинальный ответ сохранён; 5. Т-клеточный дефект исключён.

Форма ПИД	Критерии
Дефицит IgA с дефицитом подклассов IgG	1. рецидивирующие и тяжёлые бактериальные инфекции; 2. IgA отсутствует, IgG и IgM в норме или слегка снижены; 3. снижение подклассов IgG при двукратном измерении; 4. поствакцинальный ответ сохранён; 5. Т-клеточный дефект исключён.
Селективный дефицит IgA	1. подверженность инфекциям, аутоиммунные проявления или ПИД у членов семьи; 2. возраст старше 4 лет; 3. IgA менее 0,07 г/л при нормальных IgG и IgM; 4. вторичный генез и Т-клеточный дефект исключены; 5. поствакцинальный ответ сохранён.
Транзиторная гипогаммаглобулинемия	1. IgG ниже возрастной нормы в первые 3 года жизни (двукратно); 2. другие причины исключены; 3. спонтанное разрешение примерно после 4 лет; до разрешения ребёнка регистрируют как неклассифицируемый ПИД.

Всем пациентам с подозрением на ПИД проводят дифференциальную диагностику с другими формами ПИД.

При снижении иммуноглобулинов исключают вторичную гипогаммаглобулинемию: она встречается в 30 раз чаще, чем ПИД, не всегда сопровождается тяжёлыми инфекциями и часто транзиторна.

У всех пациентов с гипогаммаглобулинемией исключают другие заболевания и состояния, способные привести к неконтролируемому инфекционному процессу.

3.2 Жалобы и анамнез

Показания к скринингу на ПИД

1. отягощённый семейный анамнез по иммунологическим заболеваниям;
2. тяжёлые хронические или рецидивирующие инфекции, торпидные к стандартной терапии: синуситы, отиты, бронхиты, пневмонии, артриты, кишечные инфекции, менингиты, сепсис, кожные инфекции;
3. стойкий диарейный синдром, в том числе с мальабсорбцией;
4. патологическая лимфопролиферация: стойкая лимфаденопатия, спленомегалия, лимфоцитарная инфильтрация органов;
5. аутоиммунные проявления, прежде всего цитопении;
6. гранулематозное воспаление, прежде всего саркоидоподобные изменения в лёгких;
7. бронхоэктазы, особенно у молодых;
8. злокачественные новообразования лимфоидной ткани.

Особую настороженность вызывают пациенты с несколькими из этих симптомов.

Тщательно собирают семейный анамнез: смерть родственника в младенчестве или от инфекции, родственники с хроническими или атипичными инфекциями, цитопениями. При Х-сцепленной агаммаглобулинемии семейный анамнез прослеживается почти у половины пациентов.

3.3 Общий осмотр и пальпация

Всем пациентам с подозрением на ПИД проводится полный физикальный осмотр.

Оценивают

1. отставание в физическом развитии, снижение массы тела при энтеропатии;
2. лимфаденопатия (ОВИН) или гипоплазия лимфоузлов без регионарного увеличения при активной инфекции (агаммаглобулинемия);
3. гепато- и спленомегалия;
4. гипопротеинемические отёки;
5. «барабанные палочки», «часовые стёкла», деформация грудной клетки и суставов;
6. кожные сыпи, фурункулы, абсцессы, рубцы.

3.4 Иммуноглобулины A, G, M и белковые фракции

Общий белок и белковые фракции (электрофорез) — для выявления изменения гамма-глобулинов.

Всем пациентам с клиническими признаками ПИД определяют IgA, IgG, IgM в крови.

Диагностические признаки

1. гипогаммаглобулинемия: IgG ниже 2 стандартных отклонений от возрастной нормы у детей, **ниже 4,5 г/л** у взрослых;
2. агаммаглобулинемия: IgG **ниже 1,0 г/л**, IgM ниже 0,2 г/л, IgA ниже 0,1 г/л при CD19+ B-клетках менее 2%.

Изменения подтверждают как минимум двумя исследованиями.

3.5 Субпопуляции лимфоцитов

При гипо- и агаммаглобулинемии определяют CD19+ лимфоциты — для уточнения формы ПИД.

При гипо- и агаммаглобулинемии определяют CD3+, CD4+, CD8+, CD16+/56+ лимфоциты — для исключения комбинированных ПИД.

3.6 Подтверждение ОВИН и дефицита специфических антител

При подозрении на ОВИН — одно из исследований

1. изогемагглютинины в крови;
2. переключённые B-клетки (CD19+CD27+IgD−);
3. при пограничных или нормальных иммуноглобулинах — антитела IgG к двум и более агентам до и после вакцинации.

Оценка поствакцинального ответа

1. непривитым проводят вакцинацию инактивированными вакцинами;
2. ответ на полисахаридные вакцины оценивают **не ранее 2 лет**;
3. оценку проводят до начала заместительной терапии;
4. значимо отсутствие нарастания титра в 2–4 раза **через 4–6 недель**, при сомнительном результате — повтор через 4 недели.

При подозрении на нарушение синтеза специфических антител определяют IgG к дифтерийному и столбнячному анатоксинам, менингококку, гемофильной палочке до и после вакцинации.

При подозрении на дефицит подклассов IgG (изолированный или с дефицитом IgA) исследуют подклассы IgG.

3.7 Молекулярно-генетическое исследование

Показания

1. мужчины с агаммаглобулинемией и В-клетками менее 2%: исследуют мутации гена Btk;
2. женщины, а также мужчины без мутации Btk при В-клетках менее 2%: исследуют гены других агаммаглобулинемий;
3. при неустановленной мутации: панели генов (NGS), экзомное или геномное секвенирование.

3.8 Исследования при установленном диагнозе

Вирусные и другие инфекции у пациентов с ПИД диагностируют методом ПЦР: серологические методы неинформативны.

Исследования не реже 1 раза в 6 месяцев

1. общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ;
2. общий анализ мочи;
3. биохимический анализ крови: белок и фракции, мочевина, креатинин, АСТ, АЛТ, ГГТП, ЛДГ, билирубин, глюкоза.

На заместительной терапии претрансфузионный IgG определяют **ежемесячно** до достижения целевого уровня, затем **не реже 1 раза в 6 месяцев**.

При инфекционных осложнениях верифицируют возбудителя.

3.9 Компьютерная томография органов грудной полости

Всем пациентам при установлении диагноза показана КТ органов грудной полости; при ОВИН её повторяют **не реже 1 раза в год**, поскольку интерстициальная болезнь лёгких может долго протекать бессимптомно.

3.10 УЗИ лимфатических узлов и органов брюшной полости

При ОВИН УЗИ доступных лимфоузлов и органов брюшной полости выполняют при установлении диагноза и **не реже 1 раза в год**, поскольку существует риск лимфопролиферации и малигнизации.

3.11 Биопсия

Показания к биопсии при ОВИН

1. при патологически изменённых лимфоузлах: эксцизионная биопсия с гистологией и иммуногистохимией;
2. при подозрении на интерстициальную болезнь лёгких: биопсия лёгких;
3. при поражении ЖКТ с гипогаммаглобулинемией: эндоскопическая биопсия кишки (для дифференциальной диагностики с целиакией, НЯК, болезнью Крона).

3.12 Консультации специалистов

Пациентам с установленным диагнозом показана консультация аллерголога-иммунолога **не реже 1 раза в год**. Родственникам пациентов с установленной мутацией показана консультация генетика.

Консультации смежных специалистов при соответствующих жалобах и находках

1. гастроэнтеролог;
2. пульмонолог;
3. оториноларинголог;
4. стоматолог;
5. гематолог;
6. онколог;
7. ревматолог;
8. фтизиатр.

4. Лечение

Основные направления лечения

1. заместительная терапия иммуноглобулином человека нормальным внутривенно (ВВИГ) или подкожно (ПКИГ);
2. профилактика и лечение инфекций;
3. терапия проявлений иммунной дисрегуляции.

4.1 Заместительная терапия иммуноглобулином

Регулярное введение иммуноглобулина человека нормального начинают незамедлительно после установления диагноза при агаммаглобулинемии, ОВИН и гипер-IgM-синдроме.

1. ВВИГ: 0,4–0,8 г/кг 1 раз в 3–4 недели;
2. ПКИГ: 0,4–0,8 г/кг в месяц, суммарная доза делится на несколько инъекций через равные промежутки;
3. повышенная доза 0,6–0,8 г/кг: в начале терапии, после перерыва более 3 месяцев, при клинически значимых инфекционных эпизодах и (или) осложнениях с потерей белка (энтеропатия, нефротический синдром).

Доза и кратность подбираются индивидуально с учётом бронхоэктазов, потери белка, обострения инфекций. При иммунных цитопениях возможна высокодозная терапия иммуноглобулином по клиническим рекомендациям для этой нозологии. Препараты не являются дженериками и различаются по донорам, подклассам IgG, содержанию IgA, стабилизаторам; выбор — по индивидуальным особенностям пациента.

При тяжёлых рецидивирующих инфекциях, не контролируемых антибиотиками, и (или) аутоиммунных проявлениях заместительную терапию назначают и при лёгких формах в следующих дозах.

1. дефицит специфических антител: 0,4 г/кг 1 раз в 4 недели (взрослые и дети);
2. транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия: 0,4 г/кг ежемесячно, как правило, 2–3 месяца;
3. дефицит подклассов IgG (с дефицитом IgA или без): 0,4 г/кг 1 раз в 4 недели.

Продолжительность заместительной терапии определяется клинической ситуацией.

Дозу подбирают так, чтобы претрансфузионный IgG был **более 7 г/л**.

Требования к препарату

1. препарат подбирают с учётом индивидуальной переносимости: риск реакций выше в начале терапии и при смене препарата;
2. изоосмолярные и готовые к введению растворы переносятся лучше лиофилизатов; при использовании нескольких флаконов лиофилизата риск реакций возрастает;
3. содержание IgG не менее 95%: препараты с меньшим содержанием не рекомендуются;
4. распределение подклассов IgG близко к физиологическому;
5. в производстве предусмотрены этапы элиминации и контроль парвовируса B19;
6. указано содержание IgA, поскольку его отсутствие в описании повышает риск анафилаксии.

Выбор формы введения

1. при высоком риске почечной недостаточности (возраст **старше 65 лет**, почечная недостаточность в анамнезе, сепсис, приём нефротоксичных препаратов, обезвоживание, парапротеинемия), сердечно-сосудистых заболеваниях и риске тромбоэмболий применяют 10% ВВИГ или ПКИГ; при заболеваниях почек предпочтителен ВВИГ со стабилизатором мальтозой;
2. при затруднённом венозном доступе, особенно у детей, применяют ПКИГ;
3. при системных реакциях на внутривенное введение препарат ВВИГ меняют или переходят на ПКИГ;
4. при потере белка (нефротический синдром, энтеропатия) применяют ПКИГ.

Плохая переносимость ВВИГ при невозможности смены препарата

1. начальная скорость 0,01 мл/кг/мин с повышением каждые 15–30 минут до 0,08 мл/кг/мин;
2. премедикация НПВП, антигистаминными средствами, системными глюкокортикоидами;
3. прегидратация #натрия хлоридом за 30 минут: взрослым 500 мл, детям 10–20 мл/кг.

Иммуноглобулин для внутримышечного введения для заместительной терапии категорически не рекомендуется: он инактивируется в месте введения и имеет низкую биодоступность.

4.2 Профилактика и лечение инфекций

Режимы антибиотикотерапии

1. курс для лечения обострения;
2. интермиттирующая профилактическая антибиотикотерапия короткими или длительными курсами;
3. персистирующая профилактическая антибиотикотерапия: пожизненный приём антибактериальных препаратов.

Роль антибиотикотерапии в зависимости от тяжести формы

1. **тяжёлые формы (ОВИН, агаммаглобулинемия, гипер-IgM)**: антибиотики назначают в дополнение к заместительной терапии при хронических очагах инфекции; при неконтролируемой инфекции увеличивают дозу или частоту введения иммуноглобулина.
2. **лёгкие формы (транзиторная гипогаммаглобулинемия, дефицит IgA, подклассов IgG, специфических антител)**: антибиотики являются терапией первой линии; заместительную терапию рассматривают только при инфекции, не контролируемой антибиотиками, в том числе в персистирующем режиме.

Рекомендуются раннее назначение, комбинированные и пролонгированные курсы антимикробной, противовирусной и противогрибковой терапии: стандартной длительности может быть недостаточно для элиминации возбудителя.

При недостаточном контроле инфекций назначают профилактическую антибиотикотерапию короткими или длительными курсами. Как правило, достаточно интермиттирующего режима; препарат, дозу и длительность определяет лечащий врач. При сезонных обострениях назначают сезонные курсы.

#Амоксициллин + клавулановая кислота

1. дети: 10–20 мг/кг 1 или 2 раза в день;
2. взрослые: 500–1000 мг 1 или 2 раза в день.

#Ко-тримоксазол

1. дети: 5 мг/кг в день или 2 раза в день, ежедневно или 3 дня в неделю;
2. взрослые: 5 мг/кг в день или 3 раза в неделю (по клиническим показаниям).

#Азитромицин

1. дети: 10 мг/кг 1 раз в неделю или 5 мг/кг через день 3 дня в неделю;
2. взрослые: 500 мг 1 раз в неделю или 250 мг через день 3 раза в неделю.

#Кларитромицин

1. дети: 7,5 мг/кг в день или 2 раза в день;
2. взрослые: 500 мг в день или 2 раза в день.

#Доксициклин

1. дети старше 8 лет: 25–50 мг 1 или 2 раза в день;
2. взрослые: 100 мг 1 или 2 раза в день.

#Тобрамицин ингаляционно

1. дети старше 6 лет и взрослые: 300 мг 2 раза в день, курс 28 дней, затем перерыв 28 дней.

При неэффективности или плохой переносимости этих режимов может быть выбран любой другой антибактериальный препарат системного действия.

Методы лечения иммунной дисрегуляции имеют ограниченную доказательную базу и подбираются индивидуально.

Санаторно-курортное лечение проводится по профилю осложнений; показаны также психологическая реабилитация и социальная адаптация.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания к плановой госпитализации

1. первичное установление диагноза при симптомах ПИД;
2. коррекция терапии в специализированном центре;
3. осложнения, требующие стационарного лечения: аутоиммунные, малигнизация, энтеропатия.

Показания к экстренной госпитализации

1. состояния, угрожающие жизни и требующие экстренной медицинской помощи.

Критерии выписки

1. стабилизация состояния;
2. длительность стационарного лечения определяется характером и тяжестью инфекционных и неинфекционных осложнений.

Пациент наблюдается врачом по месту жительства и обеспечивается иммуноглобулином и препаратами для контроля иммунной дисрегуляции. На заместительной терапии обследование на осложнения проводится не реже 1 раза в год.

5.2 Профилактика

Перинатальный и ранний постнатальный скрининг агаммаглобулинемий, транзиторной гипогаммаглобулинемии, части гипер-IgM-синдромов и ранней ОВИН проводится определением TREC и KREC в мазках-отпечатках.

Всем пациентам рекомендуются ежегодная вакцинация против гриппа инактивированной вакциной и вакцинация против пневмококковой и Hib-инфекции; предпочтительны конъюгированные и адъювантные вакцины.

При ОВИН, агаммаглобулинемии, гипер-IgM-синдроме живые вакцины не рекомендуются.

Вакцинация против ветряной оспы, паротита, кори, краснухи возможна при CD4+ более 500 кл/мм^3 у взрослых, более 1000 — у детей **от 1 до 6 лет**, более 1500 — у детей **до 1 года**.

При дефиците изотипа иммуноглобулинов или лёгких цепей с нормальным числом В-лимфоцитов вакцинация проводится по национальному календарю.

В план вакцинации окружения пациента входят

1. вакцинация по национальному календарю, если она не проведена ранее;
2. ежегодная вакцинация против гриппа инактивированной вакциной;
3. иммунизация против пневмококковой и Hib-инфекции.

Для вакцинации окружения против гриппа и полиомиелита препаратами выбора являются инактивированные цельные вакцины.

5.3 Беременность

ПИД не является противопоказанием к беременности и родам. Метод родоразрешения выбирают по акушерским показаниям.

1. совместное ведение аллергологом-иммунологом и акушером-гинекологом;
2. тщательный контроль инфекционного процесса;
3. увеличение дозы иммуноглобулина человека нормального; доза и интервал подбираются по претрансфузионному IgG, частоте инфекций и весу пациентки;
4. после кесарева сечения курсы антибиотиков **в 2–3 раза** длиннее стандартных.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Первичные иммунодефициты с преимущественной недостаточностью синтеза антител»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.05.2022
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2024 года (по тексту КР) — срок пересмотра прошёл
Код в рубрикаторе	735_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Национальная ассоциация экспертов в области первичных иммунодефицитов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В списке сокращений перепутаны расшифровки: «АСТ — аланинаминотрансфераза», «АЛТ — аспартатаминотрансфераза»; правильно наоборот (АСТ — аспартатаминотрансфераза).
- В таблице 1 строка «Гипер-IgM-синдром» приведена дважды, а пороги наивных CD4+ в ней содержат два значения для одной группы «2–6 лет» (30% и 25%).

Клинические рекомендации

Перелом верхней челюсти

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S02.4** — Перелом скуловой кости и верхней челюсти
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/632_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Перелом верхней челюсти представляет собой повреждение верхней челюсти с нарушением её целостности. Переломы по типу Ле Фор, как правило, сопровождаются сотрясением (ушибом) головного мозга и переломом основания черепа.
- При повреждении ЛОР-органов (гемосинус и др.) показана консультация оториноларинголога. При нарушении стенок верхнечелюстной пазухи назначают деконгестанты для уменьшения отёка слизистой оболочки пазухи и соустья.
- Всем пациентам выполняется рентгенография не менее чем в 2 проекциях, при планировании операции дополнительно КТ челюстно-лицевой области. Через **6 недель** после операции выполняют контрольную томографию для подтверждения консолидации и исключения посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.
- Хирургическое лечение (открытая репозиция и остеосинтез) показано при переломе с выраженным смещением отломков. Всем оперируемым пациентам проводится периоперационная антибиотикопрофилактика: разовая доза внутривенно за **30–60 минут** до разреза.
- Рентгенологически подтверждённый перелом верхней челюсти является показанием к экстренной госпитализации.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Гемосинус — скопление крови в придаточных пазухах носа.

Назоликворея — ликворея в полость носа через дефект твёрдой мозговой оболочки в передней черепной ямке. Отоликворея — истечение ликвора через наружный слуховой проход через дефект твёрдой мозговой оболочки в средней черепной ямке.

Симптом «носового платка» — чистый носовой платок, смоченный ликвором, при высыхании остаётся мягким, а смоченный носовым отделяемым становится жёстким («накрахмаленным»). Проба «двойного пятна» — кровь образует на марлевой салфетке бурое пятно в центре, а по периферии — жёлтый венчик цереброспинальной жидкости.

Симптом «очков» — кровоизлияние в клетчатку век.

Симптом Малевича («разбитого горшка») — признак перелома скуловой кости, верхней челюсти: при перкуссии зубов слышен глухой дребезжащий звук, как от треснувшего глиняного горшка.

Симптом Герена — боль по ходу щели перелома при надавливании указательным пальцем на крючки крыловидных отростков клиновидной кости (снизу вверх).

Синдром повреждения верхней глазничной щели — офтальмоплегия, птоз, отсутствие чувствительности верхнего века и кожи лба, расширение и фиксированное положение зрачка.

Средняя зона лицевого черепа — зона между линией по верхним краям глазниц и линией смыкания зубов; включает кости носа, стенки глазниц, скуловые кости и дуги, верхние челюсти.

2.2 Этиология и эпидемиология

Перелом возникает либо в результате прямого удара, либо вследствие сдавления лицевого черепа. Перелом Ле Фор I обычно возникает при действии горизонтальной силы, приложенной к передней части альвеолярного отростка. Локализация и характер переломов Ле Фор II и III зависят не столько от точки приложения силы, сколько от её направления относительно франкфуртской горизонтали: горизонтальный удар в верхнюю половину средней зоны лица обычно приводит к перелому Ле Фор II, косой удар, направленный вниз, — к перелому Ле Фор III.

Переломы верхней челюсти составляют 2–5% переломов лицевого черепа. Чаще всего встречается перелом Ле Фор I (52–53%), затем Ле Фор II (35–37%), реже всего — Ле Фор III (13–15%). Ведущая причина — дорожно-транспортная травма (63%), далее следуют падение с высоты (27%) и бытовая травма (10%). Повреждение органа слуха (барабанной перепонки, слуховых косточек) наблюдалось в 1,3% случаев, а травма верхней челюсти в 10% случаев сопровождалась субарахноидальным кровоизлиянием.

2.3 Классификация

Классификация неогнестрельных переломов тела верхней челюсти (Le Fort, 1901)

Тип по Ле Фор	Линия перелома и признаки
I (нижний, перелом Герена)	отделение альвеолярного отростка и твёрдого нёба: от основания грушевидного отверстия через скулоальвеолярный гребень и бугор к крыловидным отросткам; смещение небольшое, возможно носовое кровотечение (повреждена слизистая оболочка дна верхнечелюстной пазухи и полости носа)
II (средний, суборбитальный, пирамидальный)	через носолобный шов, внутреннюю и нижнюю стенки глазницы к скуловерхнечелюстному шву; отрыв верхней челюсти с костями носа; носовое кровотечение, «симптом очков», отёк, нарушение прикуса
III (верхний, суббазальный, черепно-лицевое разъединение)	полное отделение лицевых костей от основания черепа, в отличие от I и II типов — с переломом скуловой кости; симптомы выражены резче

Изолированные типы Ле Фор встречаются редко; чаще сочетание типов с одной или разных сторон. Варианты Вассмунда близки к Ле Фор II и III, но кости носа остаются неподвижными.

Другие признаки классификации переломов верхней челюсти

1. по виду перелома: сагиттальные (односторонние), переломы альвеолярного и лобного отростков, твёрдого нёба, оскольчатый перелом передней стенки верхнечелюстной пазухи, переломы с повреждением назоорбитоэтмоидального комплекса;
2. по давности: свежие (**до 14 дней**), застарелые (14–28 дней), неправильно консолидированные (более 28 дней, кодируются как T90.2);
3. по линии перелома: линейные, оскольчатые;
4. по механизму: огнестрельные (классификация Д. Е. Танфильева) и неогнестрельные.

2.4 Клиническая картина

Признаки перелома

1. быстро нарастающий отёк лица, кровоизлияние в параорбитальную клетчатку (симптом «лица панды»);
2. носовое кровотечение, иногда с назальной ликвореей;
3. подкожная эмфизема и крепитация (воздух из воздухоносных путей);
4. симптом «плавающего нёба» — подвижность верхней челюсти при раскачивании;
5. симптом «ступеньки» в области скуловерхнечелюстного сочленения и скулоальвеолярного гребня;
6. нарушение прикуса, часто открытый прикус;
7. удлинение или уплощение средней зоны лица;
8. положительные симптомы Малевича и Герена.

Переломы часто сочетаются с переломами костей носа, дна глазницы и лобной пазухи, повреждением органа зрения и ЛОР-органов, черепно-мозговой травмой.

Подвижность костей носа и увеличение межкантального расстояния указывают на повреждение назоорбитоэтмоидального комплекса. При повреждении скуловых костей возможен «скуловой синдром»: снижение чувствительности и функции мимических мышц.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: факт травмы, носовое кровотечение;
2. жалоб: отёк, кровоподтёки, боль, носовое кровотечение, онемение кожи лица и зубов, изменение формы лица и прикуса, ограничение открывания рта;
3. физикального обследования: деформация, патологическая подвижность и крепитация отломков, подкожная эмфизема, затруднение носового дыхания, гипестезия, звук «треснувшего горшка»;
4. инструментального обследования: линии переломов и смещение фрагментов.

3.2 Жалобы и анамнез

Оценивают сознание, факт и длительность потери сознания, амнезию, головокружение, тошноту, рвоту, головную боль для верификации черепно-мозговой травмы и консультации невролога или нейрохирурга.

Уточняют механизм, дату, время и место травмы. При противоправных действиях или ДТП сообщают в правоохранительные органы.

3.3 Физикальное обследование: осмотр, пальпация, перкуссия

Всем пациентам выполняются визуальный осмотр, пальпация и перкуссия челюстно-лицевой области.

Определяют прикус: смещение отломков изменяет соотношение верхней и нижней зубных дуг.

Оценивают чувствительность лица: часто снижена в зоне подглазничного нерва (нижнее веко, подглазничная область, скат носа, верхняя губа, зубы на стороне травмы).

Оценивают симптом «очков».

При переломе верхней челюсти он появляется незамедлительно и распространён; при изолированном переломе основания черепа — не ранее чем **через 12 часов** (чаще через 24–48 часов) и не выходит за пределы круговой мышцы глаза.

При подозрении на перелом основания черепа для выявления ликвореи применяют пробу «двойного пятна» или «носового платка». Выявить ликворею сложно из-за сопутствующего кровотечения.

Оценивают энофтальм, гипофтальм, экзофтальм, глазодвигательные нарушения, остроту зрения и диплопию для выявления переломов стенок глазницы, ретробульбарной гематомы, синдрома верхней глазничной щели.

Подвижность отломков определяют, захватив альвеолярный отросток во фронтальном отделе и осторожно смещая челюсть вперёд-назад; пальцами другой руки при этом контролируют область носа и нижнеглазничный край.

3.4 Лабораторные исследования перед операцией и определение этанола

Перед операцией выполняются лабораторные исследования для исключения противопоказаний к ней. При подозрении на алкогольную интоксикацию, при ДТП или производственной травме определяют этанол в крови или моче.

3.5 Рентгенография и компьютерная томография

Всем пациентам выполняется рентгенография не менее чем в 2 проекциях (прямая и боковая проекции черепа, аксиальная и полуаксиальная); при планировании операции необходима КТ челюстно-лицевой области. Переломы без смещения на рентгенограммах выявляются трудно, поэтому при необходимости выполняют КТ или конусно-лучевую томографию.

3.6 Консультации специалистов

Всем пациентам на диагностическом этапе показана консультация нейрохирурга или невролога для исключения черепно-мозговой травмы.

При признаках повреждения ЛОР-органов (гемосинус и др.) необходима консультация оториноларинголога для уточнения диагноза и тактики обследования.

При глазодвигательных нарушениях, энофтальме, гипофтальме, гифеме, анизокории, диплопии, снижении зрения пациента направляют на консультацию офтальмолога.

---

4. Лечение

4.1 Обезболивание

Обезболивание подбирают по интенсивности боли.

1. слабая боль: парацетамол;
2. умеренная боль: НПВП, парацетамол с кеторолаком или кетопрофеном, опиоиды в комбинации с неопиоидными анальгетиками;
3. интенсивная боль: опиоиды.

При черепно-мозговой травме опиоиды противопоказаны.

4.2 Антибактериальная профилактика и терапия

Периоперационная антибиотикопрофилактика (ПАП) проводится всем пациентам, которым планируется операция: разовая терапевтическая доза внутривенно капельно за **30–60 минут** до разреза, однократно.

При контаминированных операциях антибиотики вводят не более **24 часов** после операции. Все переломы верхней челюсти условно считаются открытыми.

Препараты выбора

1. #цефазолин 2,0–3,0 г (при массе тела более 120 кг 3 г) и метронидазол 0,5–1,0 г;
2. цефуроксим 1,5 г и метронидазол 0,5–1,0 г;
3. амоксициллин + клавулановая кислота 1000 мг + 200 мг.

Альтернативные препараты (аллергия на бета-лактамы, высокий риск MRSA)

1. ванкомицин 15 мг/кг за **120 минут** до разреза;
2. #клиндамицин 0,6–0,9 г, при необходимости в сочетании с #гентамицином 1,5 мг/кг (не более 120 мг; дозу рассчитывают на идеальную массу тела).

Повторная интраоперационная доза вводится при операции длительнее 2 периодов полувыведения препарата и при массивной кровопотере.

При инфицированной ране (старая травма, гнойное отделяемое, нежизнеспособные ткани) всем пациентам проводится антибиотикотерапия.

При нарушении целостности стенок верхнечелюстной пазухи назначают деконгестанты местно, чтобы уменьшить отёк слизистой оболочки пазухи и соустья, улучшить дренаж и предупредить воспаление. Конкретные препараты и дозы в рекомендации не указаны.

4.3 Иммобилизация и ортопедическое лечение

При подозрении на перелом выполняют транспортную иммобилизацию (подбородочно-теменная повязка, пращевидная повязка) для уменьшения боли и кровотечения до решения о лечении. Противопоказания: бессознательное состояние, тошнота, рвота (угроза асфиксии).

Ортопедический метод применяют для попытки репозиции и иммобилизации отломков: назубные шины или внутрикостные винты с межчелюстной резиновой тягой и подбородочной повязкой, при беззубых челюстях шина Порта.

Противопоказания

1. черепно-мозговая травма средней и тяжёлой степени;
2. нестабильная гемодинамика;
3. тошнота и рвота (опасность аспирационной асфиксии);
4. выраженное смещение отломков, при котором ортопедическое лечение нецелесообразно и сразу требуется хирургическо-ортопедическое или хирургическое лечение.

После вмешательства оценивают восстановление прикуса и выполняют контрольную рентгенографию или КТ.

4.4 Хирургическое лечение

Показанием к хирургическому лечению является перелом с выраженным смещением отломков, противопоказанием — крайне тяжёлое состояние пациента, не позволяющее выполнить точную открытую репозицию и иммобилизацию отломков.

При тяжёлой сочетанной травме открытую репозицию и фиксацию выполняют после стабилизации состояния (принцип Damage Control).

Накостный остеосинтез выполняют под общим обезболиванием; интубацию целесообразно проводить через носовые ходы, чтобы трубка не мешала восстановлению прикуса. При выраженной деформации носовых ходов — интубация через рот с выведением трубки через подподбородочный разрез или временная трахеостома.

При смещении и подвижности отломков выполняют остеосинтез титановыми или биодеградируемыми накостными пластинами и винтами. После операции оценивают прикус и выполняют контрольную КТ.

При тяжёлой сочетанной челюстно-лицевой травме в качестве противошоковой меры первого этапа Damage Control может применяться хирургическо-ортопедический способ лечения: он малотравматичен и непродолжителен.

Вопрос об удалении нерассасывающихся накостных пластин и винтов после консолидации отломков решается индивидуально и строго по показаниям.

4.5 Диетотерапия

При нарушении сосания, жевания и глотания — первая челюстная диета (кормление через зонд); при сохранённых глотании и сосании — вторая челюстная диета (кашицеобразная пища).

4.6 Медицинская реабилитация

Медицинская реабилитация показана всем пациентам после хирургического лечения.

Этапы реабилитации

1. первый этап: **с 7-х по 10-е сутки** (в стационаре 3–5 дней, затем амбулаторно 10–15 дней);
2. второй этап: **с 15-х по 45-е сутки**, включая профилактику посттравматического верхнечелюстного синусита и контрактуры.

Межчелюстные тяги заменяют по мере ослабления, но не реже **1 раза в 7 дней**.

При черепно-мозговой травме физиотерапия противопоказана.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показанием к экстренной госпитализации является рентгенологически подтверждённый перелом верхней челюсти. Плановая госпитализация не предусмотрена, поскольку перелом является неотложным состоянием.

Показания к выписке

1. неосложнённый послеоперационный период, удовлетворительное положение отломков, отсутствие ликвореи и прогрессирующих гнойно-воспалительных процессов;
2. перевод в другое учреждение;
3. требование пациента или законного представителя;
4. несоблюдение режима, если это не угрожает жизни.

5.2 Диспансерное наблюдение

При выписке по показаниям проводится профилактический осмотр оториноларинголога, офтальмолога, невролога или нейрохирурга.

Всем пациентам через **6 недель** после операции выполняется контрольная томография лицевого черепа для подтверждения консолидации отломков и исключения посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.

Неблагоприятно влияют на исход

1. инфекционные осложнения;
2. несоблюдение режима местной контактной гипотермии, гигиены полости рта, диеты и ограничений жевательной нагрузки;
3. контактные виды спорта в течение **3 месяцев**;
4. пропуск контрольных осмотров.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Перелом верхней челюсти»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 17.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	632_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых расхождений в тексте рекомендации при сверке не найдено.

Клинические рекомендации

Полипозный риносинусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J33.0** — Полип полости носа **J33.1** — Полипозная дегенерация синуса **J33.8** — Другие полипы синуса **J33.9** — Полип носа неуточненный
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/890_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз устанавливают на основании:
  1. жалоб и анамнеза;
  2. данных осмотра;
  3. передней риноскопии;
  4. эндоскопии полости носа и носоглотки;
  5. компьютерной томографии (КТ) околоносовых пазух.
- Препаратом выбора является мометазон в форме назального спрея по 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки, курс **3–6 месяцев**. Если симптомы не уменьшаются **в течение 5–6 недель**, рассматривают вопрос о хирургическом лечении.
- Системная антибактериальная терапия при полипозном риносинусите не рекомендуется.
- Генно-инженерная биологическая терапия (дупилумаб, омализумаб или меполизумаб) рекомендуется:
  1. при тяжёлом течении;
  2. при сочетании с бронхиальной астмой.
- Показания к хирургическому лечению:
  1. неэффективность медикаментозной терапии;
  2. распространённый полипоз.

  Оптимальным методом является функциональная эндоскопическая риносинусохирургия.
- В течение первого года после операции пациента осматривают **каждые 3 месяца**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Полипозный риносинусит (ПРС): фенотип хронического риносинусита, гетерогенное по этиологии и патогенезу хроническое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух (ОНП) продолжительностью **более 12 недель**.

Сопровождается

1. ремоделированием слизистой оболочки;
2. образованием и рецидивирующим ростом полипов.

Полипы носа представляют собой доброкачественные новообразования слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.

Т2-эндотип ПРС характеризуется воспалением с эозинофилией крови или ткани либо с повышенным уровнем общего иммуноглобулина Е (IgE). К нему относятся эозинофильный хронический риносинусит, аллергический грибковый риносинусит и центральная компартментная атопическая болезнь (CCAD), то есть изолированные полипозные изменения слизистой оболочки верхней и средней носовых раковин и задневерхних отделов перегородки носа у пациентов с установленной аллергией к ингаляционным аллергенам.

2.2 Этиология и патогенез

В развитии ПРС участвуют

1. нарушения врождённого и адаптивного иммунитета;
2. аллергия;
3. генетически обусловленные заболевания: иммунодефициты, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия;
4. изменения внутриносовой анатомии;
5. бактериальная, грибковая и вирусная инфекция.

Вместе или по отдельности эти факторы поддерживают хроническое воспаление слизистой оболочки носа, которое приводит к образованию полипов и рецидивам.

Эозинофильный и неэозинофильный эндотипы ПРС различаются клиническими проявлениями, течением и ответом на лечение.

Из анатомических изменений у больных риносинуситом наиболее часто встречаются искривление перегородки носа (36%), concha bullosa (30%), клетки Оноди (12%) и клетки Галлера (6%), реже парадоксальный изгиб средней носовой раковины (3%) и пневматизация крючковидного отростка (2%).

2.3 Классификация

Единая классификация отсутствует. По клиническим и эндоскопическим данным выделяют три стадии:

1. полипы ограничены средним носовым ходом;
2. полипы выходят за пределы среднего носового хода;
3. полипы обтурируют соответствующую половину носа.

Для эндоскопической оценки применяется шкала Lund–Kennedy: полипы, отёк и отделяемое оцениваются отдельно справа и слева, каждый признак от 0 до 2 баллов.

2.4 Шкала Lund–Kennedy

Признак	0 баллов	1 балл	2 балла
Полипы	Полипы отсутствуют	Полипы в пределах среднего носового хода	Полипы распространяются за пределы среднего носового хода
Отёк	Отёк отсутствует	Умеренный отёк	Значительный отёк
Отделяемое	Отделяемое отсутствует	Прозрачное отделяемое	Густое гнойное отделяемое

Шкала Lund–Mackay по данным КТ, справа и слева отдельно

1. каждая пазуха: 0 баллов без изменений, 1 балл при частичном затенении, 2 балла при тотальном затенении;
2. остиомеатальный комплекс: 0 баллов, если интактен, 2 балла при обтурации;
3. сумма для каждой стороны от 0 до 12 баллов, общая сумма от 0 до 24.

> Таблица шкалы Lund–Mackay в приложении Г3 не совпадает с текстом раздела 1.5. Верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости указаны в ней дважды, задние клетки решётчатой кости отсутствуют. Остиомеатальный комплекс в таблице оценивается в 0, 1 или 2 балла, в тексте только в 0 или 2 балла. В строке «Общее количество баллов» справа указаны 0, 7 и 14, слева 0, 1 и 2, хотя согласно ключу под таблицей сумма составляет от 0 до 12 на сторону. Расчёт следует проводить по тексту раздела 1.5.

По гистологическому строению различают отёчные полипы с преимущественно эозинофильной инфильтрацией (70–85% клеток), фиброзные полипы с преобладанием нейтрофилов, полипы с гиперплазией серозно-слизистых желёз и полипы с атипией стромы.

2.5 Клиническая картина

Основные симптомы

1. заложенность носа;
2. слизистые или слизисто-гнойные выделения, стекание отделяемого по задней стенке глотки;
3. ощущение тяжести и давления в области носа и в проекции околоносовых пазух;
4. диффузная головная боль;
5. снижение или отсутствие обоняния.

В ряде случаев

1. жжение и раздражение в горле, кашель, охриплость;
2. недомогание, снижение работоспособности, сонливость.

Необходимо оценить выраженность и продолжительность симптомов. При обострении симптомы усиливаются.

2.6 Жалобы и анамнез

Группы жалоб

1. назальные: затруднённое носовое дыхание, выделения из носа, снижение или отсутствие обоняния;
2. болевые: лицевая боль, ощущение распирания и давления в области лица, головная и зубная боль;
3. оро- и назофарингеальные: неприятный запах изо рта, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель, заложенность или боль в ушах;
4. системные: недомогание, утомляемость, снижение работоспособности.

Такое разделение позволяет подтвердить диагноз, оценить степень тяжести и выявить факторы, влияющие на выбор тактики лечения.

При сборе анамнеза уточняют время и причины появления симптомов, последовательность их развития, выраженность и динамику, влияющие на них факторы, ранее проведённые обследования и лечение.

Отдельно выясняют

1. связь симптомов с сезонными или круглогодичными аллергенами;
2. непереносимость ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);
3. симптомы бронхиальной астмы;
4. ПРС у близких родственников;
5. одно- или двусторонний характер симптомов;
6. рецидивирующие носовые кровотечения.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Обязательные критерии

1. **две жалобы и более**, одна из которых: заложенность носа или выделения из носа.

Возможные симптомы

1. боль и давление в проекции околоносовых пазух;
2. снижение или отсутствие обоняния.

Подтверждение

1. передняя риноскопия;
2. эндоскопическая ревизия полости носа и носоглотки;
3. КТ околоносовых пазух.

Диагностическая специфичность повышается при сочетании двух или более субъективных симптомов с объективными признаками заболевания (данными эндоскопии носа и лучевых методов исследования).

3.2 Степень тяжести

Степень тяжести у всех пациентов оценивают по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Пациент оценивает выраженность симптома от 0 (симптом отсутствует) до 10 баллов (максимальная выраженность).

1. лёгкое течение: **0–3 балла**;
2. умеренное: **3–7 баллов**;
3. тяжёлое: **7–10 баллов**.

Значимое влияние на качество жизни оказывают симптомы выраженностью **5 баллов и более**.

3.3 Осмотр оториноларинголога

Осмотр показан всем пациентам с подозрением на ПРС или с установленным диагнозом.

Диагностические признаки

1. болезненность при пальпации и перкуссии в проекции околоносовых пазух;
2. признаки назальной обструкции: затруднённое носовое дыхание, гнусавость;
3. вязкое слизистое или слизисто-гнойное отделяемое;
4. полипы, при длительном течении и распространённом процессе видимые уже в преддверии носа;
5. в ряде случаев расширение спинки наружного носа.

3.4 Передняя риноскопия

Выполняется всем пациентам: оценивает распространённость процесса и сопутствующую внутриносовую патологию.

3.5 Эндоскопическая ревизия полости носа и носоглотки

Выполняется всем пациентам для определения локализации и распространённости изменений слизистой оболочки.

Эндоскопия позволяет дифференцировать ПРС от заболеваний со сходной симптоматикой (новообразований, гипертрофии глоточной миндалины и задних концов нижних носовых раковин) и в сочетании с жалобами и анамнезом значительно повышает точность диагностики: специфичность 84%, чувствительность 66%.

3.6 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания

1. каждый пациент: оценка распространённости полипоза, состояния внутриносовых структур и костных стенок пазух.

Для повторных исследований в динамике вместо мультиспиральной КТ может применяться конусно-лучевая томография носа и околоносовых пазух, поскольку она сопровождается меньшей лучевой нагрузкой и не приводит к превышению годовой дозы на одну анатомическую зону.

3.7 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух

Показания

1. подозрение на новообразование полости носа и околоносовых пазух (дополнительно к КТ).

Рентгенография околоносовых пазух дешевле и доступнее, однако при ПРС она малоинформативна по сравнению с КТ.

3.8 Патолого-анатомическое исследование

Операционный материал исследуют у всех пациентов, чтобы дифференцировать субтипы полипозного риносинусита.

3.9 Цитологическое исследование

Выполняется всем пациентам: выявляет аллергическое воспаление и помогает выбрать тактику лечения.

Диагностические признаки

1. содержание эозинофилов **более 10%** в поле зрения свидетельствует о выраженном аллергическом компоненте.

3.10 Консультации пульмонолога и аллерголога-иммунолога

Показания

1. подозрение на бронхиальную астму или атопию: консультация пульмонолога и (или) аллерголога-иммунолога.

3.11 Исследование скорости мукоцилиарного транспорта (сахариновый тест)

Показания

1. подозрение на первичную цилиарную дискинезию: исследование скорости мукоцилиарного транспорта сахариновым тестом.

---

4. Лечение

Медикаментозное и хирургическое лечение значительно и практически в одинаковой степени улучшают качество жизни при ПРС, что подтверждает приоритетное значение адекватной медикаментозной терапии.

4.1 Ограниченный полипоз (полипы в пределах среднего носового хода)

Кортикостероиды в форме назальных спреев применяют в качестве стартовой терапии при ограниченном полипозе, когда полипы не выходят за пределы среднего носового хода, а также в пред- и послеоперационном периоде.

Мометазон, назальный спрей

1. стартовая доза: по 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки, курс **3–6 месяцев**;
2. после достижения эффекта: по 2 впрыскивания в каждую половину носа 1 раз в сутки (200 мкг в сутки).

Предпочтение отдаётся препаратам с высокой топической активностью и низкой биодоступностью, поскольку они безопаснее при длительном применении. Назальные кортикостероиды уменьшают размеры полипов и заложенность носа, улучшают обоняние, предупреждают рецидивы и повышают качество жизни.

Если симптомы не уменьшаются **в течение 5–6 недель** применения мометазона, рассматривают вопрос о хирургическом лечении.

4.2 Системные кортикостероиды

Показания к системным кортикостероидам:

1. гиперреактивность бронхов, бронхиальная астма;
2. непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов;
3. рефрактерное течение ПРС;
4. выраженная атопия;
5. уменьшение воспаления в пред- и послеоперационном периоде.

Преднизолон внутрь, в таблетках

1. недостаточный контроль симптомов назальными кортикостероидами: коротким курсом 30–60 мг в сутки, **14 дней**.

Длительный или частый приём системных кортикостероидов может повышать риск нежелательных явлений и осложнений.

4.3 Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Блокаторы лейкотриеновых рецепторов применяют дополнительно к системным кортикостероидам или вместо них при их непереносимости, а также при рефрактерном к кортикостероидам течении ПРС.

4.4 Системная антибактериальная терапия

Системная антибактериальная терапия при ПРС не рекомендуется, поскольку доказательств её эффективности недостаточно, тогда как риски (развитие резистентности микрофлоры, анафилаксия, осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта) реальны.

Применение макролидов обсуждается в связи с их иммуномодулирующим и противовоспалительным действием, однако оптимальный препарат, доза и длительность терапии не определены, поэтому сделать однозначный вывод об их эффективности при ПРС не представляется возможным.

4.5 Тяжёлое течение, сочетание с бронхиальной астмой: генно-инженерная биологическая терапия

При тяжёлом течении ПРС, а также при сочетании ПРС с бронхиальной астмой для повышения эффективности лечения и снижения риска рецидивов рекомендуется генно-инженерная биологическая терапия (ГИБТ): дупилумаб, омализумаб или меполизумаб.

Препараты ГИБТ представляют собой рекомбинантные человеческие или гуманизированные моноклональные антитела класса IgG, избирательно связывающие IgE, интерлейкины или субъединицы их рецепторов (ИЛ-5, ИЛ-4/13).

Биологическую терапию назначают при двустороннем полипозе и хирургических вмешательствах в анамнезе, если выполнены **три критерия** из пяти:

1. признаки Т2-воспаления: эозинофилы в ткани не менее 10 в поле зрения, или в крови не менее 150 клеток/мкл, или общий IgE не менее 100 МЕ/мл;
2. потребность в системных кортикостероидах (2 курса и более за год или приём **более 3 месяцев**) либо противопоказания к ним;
3. значимое снижение качества жизни: SNOT-22 не менее 40;
4. аносмия по результатам исследования обоняния;
5. бронхиальная астма, требующая регулярного применения ингаляционных кортикостероидов.

Ответ на терапию оценивают по пяти критериям:

1. уменьшение размеров полипов;
2. снижение потребности в системных кортикостероидах;
3. улучшение качества жизни;
4. улучшение обоняния;
5. уменьшение влияния сопутствующих заболеваний.

Оценка ответа на генно-инженерную биологическую терапию

1. 4–5 критериев: хороший ответ;
2. 2–3 критерия: умеренный ответ;
3. 0–1 критерий: слабый ответ или его отсутствие.

Эффективность оценивают **через 6 месяцев** и **через год**. При отсутствии ответа диагноз пересматривают, лечение прекращают и при необходимости переходят на другой препарат.

Лечение длительное, при его прерывании возможен рецидив.

Беременность и лактация

1. беременность: только если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода;
2. грудное вскармливание: решение о прекращении кормления или отмене препарата принимают с учётом пользы того и другого.

Решение о продолжении терапии принимается врачом с учётом тяжести заболевания и степени контроля обострений.

Режимы дозирования генно-инженерных биологических препаратов

Препарат	Доза
Дупилумаб	Подкожно 300 мг (2 мл раствора 150 мг/мл) 1 раз в 2 недели, с 18 лет. При пропуске введения лечение возобновляется как можно скорее; у пациентов пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Омализумаб	Подкожно 75–600 мг 1 раз в 2 или 4 недели; доза и кратность введения определяются исходным уровнем IgE и массой тела и корректируются при значительном изменении массы тела.
Меполизумаб	Взрослым с плохо контролируемым тяжёлым ПРС — подкожно 100 мг 1 раз в 4 недели, длительно.

4.6 Неэффективность медикаментозной терапии, распространённый полипоз: хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению для восстановления носового дыхания:

1. неэффективность медикаментозной терапии;
2. распространённый полипоз полости носа и околоносовых пазух.

Оптимальным методом является функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРСХ) под видеоэндоскопическим контролем.

Включает

1. удаление полипозно изменённой слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух;
2. восстановление проходимости естественных соустий;
3. коррекцию анатомических нарушений: как правило, септопластику и (или) резекцию носовых раковин, а также резекцию решётчатой буллы.

В зависимости от выраженности изменений объём вмешательства может быть ограничен минимально инвазивными методиками, обеспечивающими дренирование и аэрацию околоносовых пазух.

Всем пациентам перед операцией рекомендованы кортикостероиды в форме назальных спреев, что позволяет уменьшить кровопотерю, улучшить обзор операционного поля и сократить продолжительность вмешательства.

Результат хирургического лечения во многом определяется предоперационной медикаментозной подготовкой.

4.7 Послеоперационное ведение

После любого хирургического вмешательства необходима комплексная реабилитация, направленная на восстановление носового дыхания и функции слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.

Реабилитация включает

1. охранительный режим **10–14 дней и более**;
2. санацию полости носа и околоносовых пазух под эндоскопическим контролем в режиме «ирригация–аспирация» в раннем послеоперационном периоде;
3. бережное удаление плотных продуктов воспаления и фибрина для профилактики синехий;
4. при избытке вязкого отделяемого или корках орошение полости носа 0,9% раствором натрия хлорида.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты с ПРС подлежат диспансерному наблюдению у оториноларинголога для своевременного выявления ухудшения на фоне лечения или рецидива после операции и коррекции терапии.

Специфическая профилактика ПРС отсутствует.

Назальные кортикостероиды **в течение 6–12 месяцев** в пред- и послеоперационном периоде у большинства пациентов:

1. уменьшают выраженность воспаления;
2. улучшают качество жизни;
3. снижают частоту рецидивов;
4. увеличивают продолжительность ремиссии.

Кратность осмотров определяют индивидуально; в течение первого года после операции осматривают **каждые 3 месяца**. При рецидиве, требующем повторного хирургического вмешательства, и при подозрении на осложнённое течение выполняют КТ околоносовых пазух.

Пациентам с ПРС необходимо ежедневное применение назальных кортикостероидов, нередко в течение всей жизни с небольшими перерывами.

> Длительность применения назальных кортикостероидов в рекомендации указана по-разному: курс мометазона 3–6 месяцев (раздел 3.1), в пред- и послеоперационном периоде 6–12 месяцев (раздел 5), в разделе 7 ежедневно, нередко в течение всей жизни.

Наблюдение оториноларинголога должно быть систематическим, не реже одного раза в 3 месяца. Результат лечения зависит не только от операции и опыта хирурга, но и от приверженности пациента лечению и выполнения им рекомендаций.

> В разделе 5 указано, что кратность обследований определяется индивидуально, а осмотры каждые 3 месяца необходимы в течение первого года после операции. В разделе 7 и в информации для пациента указано постоянное наблюдение не реже одного раза в 3 месяца.

Основной задачей является комплексное лечение, обеспечивающее контроль симптомов и улучшение качества жизни. В ряде случаев необходимы повторные щадящие эндоскопические вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах.

При сопутствующей бронхиальной астме показано также наблюдение аллерголога-иммунолога.

5.1 Показания к госпитализации

Обследование и лечение пациентов могут проводиться как амбулаторно, так и в условиях стационара.

Показания к плановой госпитализации:

1. функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРСХ) с одномоментной коррекцией внутриносовых структур или без неё при отсутствии противопоказаний к хирургическому лечению;
2. подбор и коррекция терапии (дневной или круглосуточный стационар);
3. проведение генно-инженерной биологической терапии.

Выписка после операции возможна при:

1. удовлетворительном общем состоянии;
2. улучшении или восстановлении носового дыхания.

Согласно алгоритму ведения пациента (приложение Б), после диагностики пациент с аллергией или бронхиальной астмой направляется к аллергологу-иммунологу или пульмонологу. При отсутствии показаний к операции наблюдение и лечение осуществляются амбулаторно; при отрицательной динамике, как и при наличии показаний, показана госпитализация в специализированный стационар для ФЭРСХ с последующим продолжением наблюдения и медикаментозного лечения.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Полипозный риносинусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	`890_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Таблица шкалы Lund–Mackay в приложении Г3 не соответствует тексту раздела 1.5: верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости указаны дважды, задние клетки решётчатой кости отсутствуют, остиомеатальный комплекс оценивается в 0–1–2 балла вместо 0 или 2, а строка «Общее количество баллов» (0–7–14 и 0–1–2) не соответствует сумме от 0 до 12 на сторону.
- Длительность применения назальных кортикостероидов указана по-разному: 3–6 месяцев (раздел 3.1), 6–12 месяцев (раздел 5), ежедневно, нередко в течение всей жизни (раздел 7).
- Кратность наблюдения в разделе 5 определяется индивидуально, с осмотрами каждые 3 месяца в течение первого года после операции; в разделе 7 указано постоянное наблюдение не реже одного раза в 3 месяца.

Клинические рекомендации

Потеря слуха, вызванная шумом

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H83.3** — Шумовые эффекты внутреннего уха **Z57.0** — Неблагоприятное воздействие производственного шума
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.03.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Ассоциация врачей и специалистов медицины труда; Национальная медицинская ассоциация сурдологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/609_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Профессиональная тугоухость: медленно развивающаяся хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость от производственного шума выше предельно допустимого уровня — **80 дБА**.
- Типичная аудиограмма: двусторонний симметричный «провал» **на 4000 Гц** (реже 3000 Гц) с подъёмом на 8000 Гц, без костно-воздушного разрыва; пороги на разговорных частотах ниже, чем на высоких, **не менее чем на 15 дБ**.
- Предварительный диагноз устанавливает оториноларинголог на периодическом медосмотре или при обращении, заключительный устанавливает только центр профпатологии.
- Подозрение на профессиональную тугоухость (двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость с типичной аудиограммой):
  1. шум на рабочем месте **до 90 дБА**: стаж **15 лет и более**;
  2. шум **более 90 дБА**: стаж **10 лет и более**;
  3. после предварительного диагноза работника направляют в центр профпатологии **в течение 30 дней**.
- Профпригодность по заключительному диагнозу:
  1. признаки воздействия шума (Z57.0): трудоспособен без ограничений;
  2. I «А» степень: трудоспособен в профессии, наблюдение в центре профпатологии **раз в год**;
  3. I «Б» степень: трудоспособен, наблюдение **2 раза в год**;
  4. II степень и выше: работа в шуме **выше 80 дБА** противопоказана, направление на медико-социальную экспертизу.
- Лечение эффективно только на ранних стадиях: при признаках воздействия шума на орган слуха (Z57.0) и I степени потери слуха. При II–III степени медикаментозное лечение малоэффективно, а при III степени и трудностях общения подбирают слуховой аппарат.
- Основу составляет профилактика: средства индивидуальной защиты органа слуха, «защита временем», медосмотры и группы диспансерного наблюдения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Потерей слуха, вызванной шумом, называют медленно развивающееся хроническое двустороннее нарушение слуха, причиной которого является производственный шум выше предельно допустимого уровня (**80 дБА**).

Поражается звуковоспринимающий отдел слухового анализатора, то есть нейроэпителий внутреннего уха; клинически это проявляется хронической двусторонней сенсоневральной тугоухостью.

Акустическая травма в этих КР не рассматривается: её тоже кодируют H83.3, но оформляют как несчастный случай на производстве.

2.2 Этиология и патогенез

Причиной является производственный шум выше гигиенических нормативов. Шум **до 90 дБА** учащает временное смещение порогов слуха после смены: это индикатор риска, а не начало профессиональной патологии; при продолжении воздействия возможен переход в постоянное смещение.

Усугубляют действие шума

1. напряжённость и тяжесть труда;
2. нагревающий микроклимат;
3. заболевания сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и иммунной систем.

Единой теории патогенеза нет. Морфологическим субстратом служит дегенерация наружных и внутренних волосковых клеток кортиева органа, причём процесс носит восходящий характер. Главной причиной гибели клеток считают оксидативный стресс: апоптоз наружных волосковых клеток проявляется временным повышением порогов, а некроз — постоянным смещением порогов и тугоухостью.

Основным звеном патогенеза являются сосудистые расстройства: снижение кровенаполнения в вертебробазилярной системе, ангиоспазм, затруднение венозного оттока. Лабиринтная артерия является концевой и не имеет коллатералей, а рецепторы улитки очень чувствительны к гипоксии.

Шум служит дополнительным фактором риска артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и нарушений вегетативной регуляции; как правило, эти экстраауральные нарушения предшествуют поражению слуха.

На большинстве производств шум действует вместе с вибрацией, инфразвуком, нервно-эмоциональным и физическим напряжением, нагревающим микроклиматом, токсическими веществами.

2.3 Классификация

Классификация потери слуха, вызванной шумом

Степень	Средний порог по воздуху на 500, 1000, 2000, 4000 Гц, дБ
Признаки воздействия шума на орган слуха	11–25
I степень (I «А», I «Б»)	26–40
II степень	41–55
III степень	56–70
IV степень	71–90

Подгруппы I степени

1. I «А»: нет экстраауральной патологии;
2. I «Б»: гипертоническая болезнь 2 степени и выше, ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга 2 степени и выше.

Подгруппы нужны для выбора лечения и чтобы предупредить работника с I «Б» о повышенном риске при продолжении работы в шуме.

«Коррекцию на возраст» не применяют: при потере на высоких частотах **более 45–50 дБ** у пожилых нельзя разграничить шум и старение.

Возрастная инволюция слуха начинается **после 35–37 лет** и к 40–49 годам даёт на речевых частотах **до 10 дБ**. Её учитывают только до стадии признаков воздействия шума (Z57.0); при порогах выше параметров пресбиакузиса степень считают от аудиометрического нуля.

2.4 Клиническая картина

Развивается медленно, обычно **10–14 лет**; первые донозологические изменения на аудиограмме возможны **при стаже 5 лет**.

Жалобы по мере развития

1. сначала появляются экстраауральные жалобы: нарушение сна, раздражительность, головная боль;
2. позже присоединяются ухудшение разборчивости речи, особенно в шуме, шум в ушах и снижение слуха.

Отоскопия

1. барабанная перепонка втянута, мутная;
2. инъекция сосудов по рукоятке молоточка;
3. световой конус укорочен.

Такая картина чаще наблюдается при сочетании шума и вибрации.

Развитие изменений на аудиограмме

1. сначала повышение порогов **на 12, 14, 16 кГц**;
2. затем «провал» **на 4000 Гц** (реже 3000 Гц) с подъёмом на 8000 Гц — на восприятие речи не влияет, выявляется только аудиометрией;
3. при продолжении шума «провал» расширяется на соседние частоты; жалоб на слух ещё нет.

Костно-воздушного разрыва нет.

Отличия от пресбиакузиса

1. пологая нисходящая кривая, наибольшее повышение порога на 4000 Гц;
2. средний порог на 500, 1000, 2000 Гц всегда ниже, чем на 3000, 4000, 6000 Гц, разница **не менее 15 дБ**;
3. пороги на 3000, 4000, 6000 Гц всегда выше, чем на 8000 Гц;
4. шум обычно не даёт потери **более 75 дБ** на высоких и **более 40 дБ** на разговорных частотах.

У работников **старше 50–55 лет** «провал» менее выражен; без прежних аудиограмм начальные признаки трудно отличить от пресбиакузиса. При сочетании шума и возраста вместо «провала» формируется «впадина».

Типичные клинико-аудиологические признаки

1. постепенное повышение порогов по типу нарушения звуковосприятия в течение нескольких лет, **не менее 5**;
2. двусторонний процесс;
3. нет костно-воздушного разрыва;
4. нисходящая кривая с «провалом» на 4000 или 3000 Гц;
5. постепенное повышение порогов на 1000 и 2000 или 3000 Гц;
6. при стаже **20 лет и более** — значительнее на речевых частотах, выраженные «провалы» на 2000 и 4000 Гц.

Самые ранние изменения выявляет вызванная отоакустическая эмиссия. Отсутствие задержанной ОАЭ **более чем в 4 частотных полосах** при нормальных тональных порогах является неблагоприятным признаком и служит показанием к динамическому наблюдению и реабилитации.

Для скрининга задержанная ОАЭ предпочтительнее ОАЭ на частоте продукта искажения.

Надпороговые и объективные тесты

1. положительный феномен ускоренного нарастания громкости, дифференциальный порог 0,6–0,4 дБ в начале; 1,5–3 дБ — при нарастании тугоухости;
2. показатели теста Si-Si растут с тугоухостью, до 100% при повышении порога **на 40 дБ**;
3. слуховое поле сужено до 90 дБ, возможен гиперакузис;
4. повышение порогов на 16, 14, 12 кГц в расширенном диапазоне;
5. тимпанограмма тип «А», акустический рефлекс сохранён (60–70 дБ), при высокой степени тугоухости не вызывается;
6. амплитуда задержанной ОАЭ снижена, выпадают частоты (прежде всего 4000 или 3000 Гц); при порогах **более 30 дБ** ОАЭ не регистрируется.

Экстраауральные проявления

1. головная боль, раздражительность, утомляемость, нарушение сна;
2. шум в ушах, головокружение с потемнением в глазах;
3. боль в области сердца, сердцебиение;
4. при осмотре: изменение сухожильно-периостальных рефлексов, тремор пальцев, стойкий дермографизм, акроцианоз, потливость, неустойчивость в позе Ромберга.

Шум вместе с вибрацией раздражает вестибулярный анализатор: «уплывание глаз», диссоциация вестибуло-окулярных реакций при калорической и вращательной пробах. Для «шумовых» профессий характерно понижение вестибулярной возбудимости.

---

3. Диагностика

Два этапа

1. предварительный диагноз — на периодическом медосмотре или при любом обращении;
2. заключительный — только учреждение профпатологии с лицензией по профпатологии, экспертизе связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности.

Критерии диагноза

1. жалобы: постепенное снижение слуха, больше на высоких частотах, низкочастотный шум в обоих ушах или в голове, хуже разборчивость речи в шуме;
2. в анамнезе нет сердечно-сосудистых болезней, церебрального атеросклероза, остеохондроза, нарушений липидного обмена, сифилиса, сахарного диабета, болезней среднего уха и носоглотки, травм головы, наследственной тугоухости, лечения аминогликозидами;
3. стаж в шуме **10 лет и более**, уровень шума **выше 80 дБА**.

При осмотре

1. пальпация уха и сосцевидного отростка безболезненна;
2. слуховой проход свободен;
3. барабанная перепонка чаще матовая, слегка втянута, световой конус укорочен, сосуды по рукоятке молоточка инъецированы.

Кровь в норме, липидный профиль нарушен.

Инструментально: двусторонняя симметричная нисходящая кривая с «провалом» на 4000 Гц, без костно-воздушного разрыва; надпороговые тесты — как в разделе «Клиническая картина». Отсутствие задержанной ОАЭ **на 4000 Гц** — ранний признак воздействия шума.

3.1 Жалобы и анамнез

Уточняют характер работы, уровень шума на рабочем месте и стаж в нём, все прежние профессии и вредные факторы, сопутствующие болезни.

Характерно для шумовой тугоухости

1. нет недавних острых заболеваний, в том числе COVID-19;
2. раздражительность, нарушение сна;
3. шум в обоих ушах или в голове раньше снижения слуха;
4. нет хронических болезней среднего уха, гипертензии, диабета, нарушений липидного обмена;
5. нет шумных увлечений: громкой музыки, стрельбы;
6. нет тугоухости у близких родственников;
7. постепенное снижение слуха;
8. «шумоопасная» профессия, стаж в шуме выше допустимого **более 8–10 лет**.

3.2 Осмотр и консультации специалистов

Всех работающих в шуме выше допустимого уровня на медосмотре осматривает оториноларинголог, чтобы выявить нарушения слуха и противопоказания к работе. При типичных жалобах и аудиограмме и стаже **10 лет и более** он вправе установить предварительный диагноз профессиональной тугоухости.

Осматривают наружное ухо и сосцевидный отросток.

Обязателен и осмотр верхних дыхательных путей, поскольку болезни носа и околоносовых пазух могут быть дополнительной причиной снижения слуха.

При подозрении на шумовую тугоухость оториноларинголог повторно осматривает пациента в учреждении профпатологии, чтобы установить заключительный диагноз, определить профпригодность и группу диспансерного наблюдения и разработать индивидуальную программу реабилитации слуха.

При углублённом обследовании в стационаре профпатологии — ежедневный осмотр оториноларинголога.

Консультация сурдолога-оториноларинголога

1. первичная консультация: при затруднительной дифференциальной диагностике;
2. повторная консультация: для углублённого обследования слуха, установления заключительного диагноза и составления программы реабилитации, в том числе слухопротезирования.

Консультации терапевта и невролога

1. первичные консультации на предварительном и периодических медосмотрах: оценка экстраауральных эффектов шума и противопоказаний к работе в шуме, лечение сопутствующих болезней;
2. повторные консультации: при установлении заключительного диагноза.

Невролог первично оценивает влияние шума на нервную систему и противопоказания к работе в шуме.

Повторный осмотр невролога проводится при установлении заключительного диагноза.

Задачи первичной консультации профпатолога по результатам медосмотра

1. противопоказания к работе в шуме;
2. возможность предварительного диагноза;
3. запрос санитарно-гигиенической характеристики условий труда;
4. направление в центр профпатологии.

По результатам повторной консультации устанавливают заключительный диагноз, определяют профпригодность и диспансерную группу.

Повторный приём профпатолога проводится в учреждении профпатологии при решении о заключительном диагнозе.

3.3 Клинические и биохимические исследования крови и мочи

Показания

1. все работники «шумоопасных» профессий и пациенты с потерей слуха, вызванной шумом.

Исследования общеклинической программы

1. развёрнутый общий анализ крови;
2. общий анализ мочи;
3. биохимический общетерапевтический анализ крови;
4. липидный профиль (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэффициент атерогенности): значим для патогенеза и выявляет дополнительные экстраауральные эффекты шума.

3.4 Электрокардиография

Показания

1. все работники «шумоопасных» профессий;
2. все пациенты с потерей слуха, вызванной шумом.

Исследование входит в программу общеклинического обследования на периодическом медосмотре и в учреждении профпатологии.

3.5 Условия аудиометрического исследования

Аудиометрию работникам в шуме проводят **не ранее чем через 14 часов** после прекращения контакта с шумом, чтобы исключить временное смещение порогов.

3.6 Камертональные пробы

Показания

1. работники «шумоопасных» профессий с жалобами на снижение слуха.

Пробы Вебера и Ринне дают ориентировочную оценку слуха и разграничивают нарушение звукопроведения и звуковосприятия.

3.7 Тональная пороговая аудиометрия

Показания

1. все работники «шумоопасных» профессий: воздушное и костное проведение в конвенциальном диапазоне.

Основной метод диагностики и дифференциальной диагностики, выявляет ранние сдвиги порогов. Типичная картина описана в разделе «Клиническая картина».

Показания к аудиометрии в расширенном диапазоне частот

1. работники «шумоопасных» профессий с жалобами на снижение слуха;
2. пациенты с потерей слуха, вызванной шумом.

Выявляет самые ранние изменения **на 12, 14, 16 кГц**, не видимые другими методами.

3.8 Надпороговые тесты

Показания

1. все пациенты с потерей слуха, вызванной шумом.

Проба Люшера, порог дискомфорта и тест Si-Si углубляют оценку слуховой функции и уточняют уровень поражения.

Речевая аудиометрия выполняется по показаниям, для профпригодности по отраслевым требованиям, прежде всего в гражданской авиации.

3.9 Импедансометрия

Показания

1. все пациенты с потерей слуха, вызванной шумом;
2. экспертиза связи заболевания с профессией, при которой исследование обязательно.

Цель: дифференциальная диагностика и определение уровня поражения слухового анализатора.

3.10 Вызванная отоакустическая эмиссия

Показания

1. все пациенты с потерей слуха, вызванной шумом.

Цель: выявление самых ранних нарушений, подтверждение степени, исключение аггравации и симуляции. Изменения появляются прежде всего в полосе 4 кГц.

Диагностические признаки

1. отсутствие ОАЭ **более чем в 4 частотных полосах**: показание к расширенному аудиологическому обследованию;
2. подавление ОАЭ **на 4 кГц** при нормальных тональных порогах: неблагоприятный признак, показание к динамическому наблюдению.

Задержанная ОАЭ предпочтительна для скрининга работающих в шуме.

ОАЭ на частоте продукта искажения уточняет степень повышения порогов и рельеф аудиограммы при экспертизе.

3.11 Слуховые вызванные потенциалы

Показания

1. сложные и спорные случаи диагностики.

Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы являются основным методом объективного определения порогов и исключения аггравации и симуляции.

В тех же случаях для объективизации порогов применяют ASSR-тест (вызванные ответы мозга на постоянные модулированные тоны).

3.12 Исследование вестибулярной функции

Показания

1. жалобы на головокружение и шаткость.

На медосмотре оценивают спонтанный нистагм, при возможности выполняют вестибулометрию.

3.13 Лучевая и ультразвуковая диагностика

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий выполняют для оценки кровоснабжения внутреннего уха.

Рентгенография шейного отдела позвоночника позволяет выявить причины нарушения кровообращения в вертебробазилярной области.

По рентгенографии околоносовых пазух оценивают состояние пазух и слуховой трубы как сопутствующих причин снижения слуха.

КТ височных костей выполняют для дифференциальной и топической диагностики по согласованию с рентгенологом, с контрастом или без него. Односторонние нарушения могут скрывать двусторонний процесс (например, нейрофиброматоз II типа).

МРТ, в том числе с контрастом, выполняют для исследования внутренних слуховых проходов, мостомозжечковых углов и задней черепной ямки.

Лечение шума в ушах и тугоухости без дифференциальной диагностики недопустимо: например, при невриноме слухового нерва витамины, ноотропы и физиотерапия могут ускорить рост опухоли.

3.14 Иные диагностические исследования

Рефлексотерапевт определяет показания и противопоказания к лечению методами рефлексотерапии.

Физиотерапевт определяет показания и противопоказания к физиотерапевтическому лечению.

3.15 Предварительный и заключительный диагноз

Критерии подозрения на профессиональную тугоухость
Двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость с типичной аудиограммой при условии:

1. шум на рабочем месте **до 90 дБА** — стаж **15 лет и более**;
2. шум **более 90 дБА** — стаж **10 лет и более**.

При признаках воздействия шума (Z57.0) на медосмотре ограничений профпригодности нет. Работника включают в группу повышенного риска и разрабатывают ему индивидуальную программу реабилитации слуха. Это донозологическое состояние, а не заболевание.

После предварительного диагноза работника **в течение 30 дней** направляют в центр профпатологии и подают извещение в Роспотребнадзор.

Связь с профессией после прекращения работы в шуме рассматривают, только если тугоухость документально подтверждена в период работы; появление или прогрессирование тугоухости после прекращения контакта с шумом основанием не является. Перерывы в стаже снижают вероятность прогрессирования.

Формулировки заключительного диагноза и профпригодность

1. признаки воздействия шума (Z57.0): трудоспособен без ограничений;
2. I «А» степень: трудоспособен в профессии при наблюдении в центре профпатологии **раз в год**, разработана программа реабилитации слуха;
3. I «Б» степень: трудоспособен при наблюдении **2 раза в год**, предупреждён о риске;
4. II степень и выше: работа в шуме **выше 80 дБА** противопоказана, направление на медико-социальную экспертизу.

---

4. Лечение

Лечение эффективно только в самых начальных стадиях — «Признаки воздействия шума на орган слуха» (Z57.0) и I степень потери слуха, и только при устранении шума. Лечение такое же, как при нейросенсорной тугоухости непрофессионального генеза: микроциркуляция внутреннего уха, мозговая гемодинамика, оксигенация.

Курсы **не менее 10 дней**, **не реже 2 раз в год**; в группе риска — раз в год.

Работникам «шумоопасных» профессий назначают охранительный слуховой режим.

4.1 Медикаментозное лечение

Шум в ушах и сенсоневральная тугоухость: «Признаки воздействия шума на орган слуха» (Z57.0) и I степень потери слуха

1. ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции;
2. периферические вазодилататоры;
3. ноотропные препараты;
4. препараты для устранения головокружения;
5. психоаналептики.

Применение вне инструкции при H83.3 допускается распоряжением Правительства № 1180-р. При II и III степени медикаментозное лечение малоэффективно.

При шуме в ушах, признаках воздействия шума (Z57.0) или I степени потери слуха применяют витамины группы B в дозах по инструкции.

Поддерживающие курсы проводят по индивидуальным показаниям с учётом соматических болезней, совместно с профильными специалистами.

4.2 Физические (нелекарственные) методы

Немедикаментозные методы значительно повышают эффективность лекарств. Все они применяются при отсутствии противопоказаний, при шуме в ушах и потере слуха от шума.

Метод	Показания
рефлексотерапия	Z57.0 и I степень
электропунктура	Z57.0 и I степень
лазеропунктура	Z57.0 и I степень
транскраниальная электростимуляция	любая степень

Метод	Показания
магнитотерапия на шейный отдел позвоночника и сосцевидные отростки	I–II степень
УВЧ на шейный отдел позвоночника и сосцевидные отростки (УДД 4)	любая степень
дарсонвализация органа слуха	любая степень
эндауральная дарсонвализация (УДД 4)	любая степень
внутриушной электрофорез лекарственных препаратов	любая степень
плазмаферез	любая степень
лекарственный ультрафонофорез	любая степень
электрофорез синусоидальными модулированными токами (УДД 4)	шум в ушах и потеря слуха
общий медицинский массаж	любая степень
медицинский массаж шеи	любая степень
массаж воротниковой области	любая степень
гипербарическая оксигенация	начальные нарушения, усиление базисной терапии
заушные блокады с лекарственными препаратами	Z57.0 и I степень, шум в ушах и в голове

4.3 Слухопротезирование

При необратимой потере слуха III степени и трудностях общения подбирают слуховой аппарат (цифровой, бинаурально или моноурально) вместе с лечебно-реабилитационными мероприятиями.

Хирургическое лечение при сенсоневральной тугоухости, в том числе шумовой, не показано.

4.4 Иное лечение

Лечебно-оздоровительный режим направлен на уменьшение стресса и экстраауральных эффектов шума.

Диетическое питание индивидуально, с учётом нарушений липидного обмена; без иных показаний — стол № 10 или 15.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Организация медицинской помощи

Порядок установления диагноза профессиональной тугоухости

1. предварительный диагноз устанавливает оториноларинголог или сурдолог любой медицинской организации амбулаторно;
2. **в течение суток** пациента направляют к профпатологу по месту жительства;
3. профпатолог подтверждает диагноз и **в 3-дневный срок** направляет извещение в Роспотребнадзор;
4. Роспотребнадзор **в 2-недельный срок** составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда;
5. профпатолог **в месячный срок** направляет пациента в учреждение профпатологии.

Документы при направлении в учреждение профпатологии

1. копия трудовой книжки;
2. выписки предварительного и периодических медосмотров;
3. результаты обследований;
4. копии аудиограмм за весь период работы в шуме;
5. санитарно-гигиеническая характеристика условий труда.

Все документы заверяются печатями.

Заключительный диагноз устанавливает врачебная комиссия учреждения профпатологии — амбулаторно или после обследования в стационаре; извещение **в 3-дневный срок** направляют в Роспотребнадзор, работодателю, страховщику и в направившую организацию.

При предварительном диагнозе показаний к госпитализации нет. Госпитализация в учреждение профпатологии проводится для углублённого обследования перед установлением заключительного диагноза.

Выписка осуществляется после решения вопроса об установлении или отсутствии заключительного диагноза.

5.2 Реабилитация

Всем работникам «шумоопасных» профессий проводят краткое профилактическое консультирование: причины и профилактика потери слуха, средства индивидуальной защиты органа слуха, здоровый образ жизни.

Медицинская реабилитация при любой степени потери слуха включает разработку индивидуальной программы реабилитации слуха.

Санаторно-курортное лечение рекомендуется всем работающим в шуме, в том числе без нарушений слуха. Его проводят в период отпуска **не реже раза в год** в санатории, дневном стационаре, профилактории или доме отдыха.

Объём лечения определяют

1. терапевт, невролог, хирург;
2. медицинский психолог или психиатр;
3. офтальмолог, оториноларинголог.

Программы оздоровления составляют с учётом шума и сопутствующих факторов, класса условий труда, здоровья работника, формы и степени тугоухости.

У всех прошедших санаторно-курортное лечение оценивают его результаты. Результатом реабилитации считают устранение проявлений тугоухости или значительное улучшение слуха, положительную динамику аудиометрии, улучшение самочувствия.

Эффективность оздоровления оценивают по медико-социальным и экономическим показателям: заболеваемость с временной нетрудоспособностью, новые случаи профессиональной тугоухости, число профнепригодных и инвалидов.

Лечебный массаж шеи и воротниковой области проводят ежедневно, курс — **до 10 процедур**.

Слуховой тренинг в шлеме виртуальной реальности применяют дополнительно при лёгкой сенсоневральной тугоухости и скрытой потере слуха: ежедневно в течение **7 дней**, занятие длится **15 минут** с паузой 2 минуты.

Вестибулярные тренировки, в том числе с применением виртуальной реальности, проводят ежедневно или через день **по 30 минут**, курс — **20 процедур**.

5.3 Первичная профилактика

Технические меры

1. специальная оценка условий труда;
2. снижение шума и усиливающих его факторов (вибрации, напряжения, вынужденной позы) до нормативов;
3. замена шумных технологий;
4. коллективная защита: шумозащитные панели, перегородки, потолки.

Средства индивидуальной защиты органа слуха

1. противошумные наушники;
2. вкладыши («беруши»);
3. шлемы и костюмы.

Средства индивидуальной защиты применяют, если коллективная защита не снижает шум до нормы; работодатель предоставляет их бесплатно.

«Защита временем»

1. 10-минутные регламентированные перерывы с подменой: при высокой нагрузке — **каждые 2 часа**, при средней — **не реже чем каждые 4 часа**;
2. работа с шумом или вибрацией **не более 2/3 смены**;
3. микропаузы в шумных операциях;
4. смена «шумоопасной» профессии на «шумобезопасную» в комплексной бригаде.

Для обоснования мер первичной профилактики рассчитывают групповой избыточный риск потери слуха от шума (приложение Г1 КР).

Вспомогательно применяют производственную гимнастику, ультрафиолетовое облучение, витамины и сбалансированное питание.

Отдых в комнатах психологической разгрузки и домах отдыха снимает негативные эффекты хронического стресса от воздействия шума.

Медицинский отбор в профессию проводят на предварительном и периодических медосмотрах по приказу Минздрава № 29н.

5.4 Диспансерное наблюдение

Периодические медосмотры представляют собой диспансеризацию трудовых коллективов; по их результатам выделяют группы динамического наблюдения.

Группы динамического наблюдения

Группа	Кто входит	Наблюдение
I «А»	практически здоровые: шум **не выше 90 дБА** при любом стаже или **выше 90 дБА** при стаже **до 10 лет**	медосмотр раз в год, профилактика, подбор и использование средств защиты
I «Б»	практически здоровые: шум **выше 90 дБА**, стаж **более 10 лет**	как I «А» + массаж воротниковой зоны 2 раза в год, рефлексотерапия раз в год
II	признаки воздействия шума на орган слуха (Z57.0)	как I «Б» + гипербарическая оксигенация, лекарства, санаторно-курортное лечение раз в год
III «А»	потеря слуха от шума I «А» степени	трудоспособен; центр профпатологии раз в год, программа реабилитации, лекарства и немедикаментозное лечение, санаторий раз в год
III «Б»	I «Б» степень: в сочетании с гипертонической болезнью или хронической ишемией мозга 2 степени и выше	как III «А» + лечение сосудистой патологии; курс и центр профпатологии 2 раза в год
III «В»	II степень и выше (H83.3, H90.3) любой этиологии	непригоден к работе в шуме, медико-социальная экспертиза; наблюдение по месту жительства 2 раза в год

При хронической сенсоневральной тугоухости любой степени составляется индивидуальная программа реабилитации слуха; её разрабатывает и контролирует оториноларинголог или сурдолог-оториноларинголог.

5.5 Факторы, влияющие на исход

Сердечно-сосудистые болезни и нарушения липидного обмена усиливают действие шума: тугоухость развивается быстрее, пороги на высоких частотах выше, типичные аудиологические признаки стираются. Шум может вызвать соматизированное депрессивное расстройство.

Усиливают вред шума

1. стрельба, охота, громкая музыка, особенно в наушниках;
2. алкоголь, курение, наркотики;
3. лечение аминогликозидами в анамнезе;
4. глухота у близких родственников;
5. травмы головы.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Потеря слуха, вызванная шумом»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 15.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее марта 2027 года
Код в рубрикаторе	`609_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Ассоциация врачей и специалистов медицины труда; Национальная медицинская ассоциация сурдологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Липиды противоречат друг другу: в разделе 1.2 при действии шума снижены ЛПВП, в критериях диагноза (раздел 2) — «повышены» общий холестерин, ЛПВП и ЛПНП.
- Стаж для подозрения на профессиональную тугоухость указан по-разному: «10 и более лет» (раздел 2), «более 8–10 лет» (раздел 2.1), 15 лет при шуме до 90 дБА и 10 лет при шуме выше 90 дБА (приложение Б).
- Для группы III «А» немедикаментозное лечение отсылает к разделу 3.2, но там хирургическое лечение (не рекомендуется); немедикаментозные методы — раздел 3.1.2.
- PDF в рубрикаторе — распознанный скан: в цитатах журнала сверки встречаются ошибки распознавания (например, «257.0» вместо Z57.0, «81-81» вместо Si-Si). Цифры таблиц сверены по изображениям страниц.

Клинические рекомендации

Простой герпес у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B00.1** — Герпетический везикулярный дерматит **B00.2** — Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит **B00.3** — Герпетический менингит (G02.0*) **B00.4** — Герпетический энцефалит (G05.1*) **B00.7** — Диссеминированная герпетическая болезнь **B00.8** — Другие формы герпетических инфекций **B00.9** — Герпетическая инфекция неуточненная **B34.9** — Вирусная инфекция неуточненная **K12.1** — Другие формы стоматита
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 27.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ); Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/492_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Простой герпес — широко распространённая вирусная инфекция, вызываемая вирусами простого герпеса 1 и 2 типов: от бессимптомного течения и поражения кожи и слизистых оболочек до тяжёлых генерализованных форм с поражением ЦНС, внутренних органов, глаз.
- При типичной манифестной локализованной форме диагноз устанавливается по клинической картине. Методом выбора лабораторного подтверждения является ПЦР соскоба с высыпаний или содержимого везикул.
- **Противовирусная терапия внутрь (эпизодическая)**
  1. первичный эпизод: ацикловир 200 мг 5 раз в сутки, валацикловир 500 мг 2 раза в сутки или #фамцикловир 250 мг 3 раза в сутки, **7–10 дней**;
  2. рецидив: те же препараты в тех же дозах, **5 дней**.

  Лечение начинают при первых признаках поражения (зуд, жжение, покраснение), при рецидиве — желательно в продромальном периоде.
- **Оториноларингологу**
  1. характерная повторяющаяся локализация высыпаний — красная кайма губ, кожа вокруг рта, крылья носа, полость рта;
  2. при частых рецидивах в анамнезе перед манипуляциями, нарушающими целостность кожи и слизистых оболочек, показана превентивная противовирусная терапия **в течение 10 дней**;
  3. герпетический стоматит сопровождается болезненными эрозиями полости рта и регионарным лимфаденитом.
- Лёгкие, среднетяжёлые и неосложнённые формы лечат амбулаторно; тяжёлые, осложнённые и диссеминированные формы подлежат госпитализации в инфекционное отделение.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Простой герпес (ПГ) — широко распространённая вирусная инфекция, вызываемая вирусами простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов, характеризующаяся многообразными проявлениями: от бессимптомного течения или поражения кожи и слизистых разной локализации до тяжёлых генерализованных форм с поражением центральной нервной системы, внутренних органов, глаз.

2.2 Этиология и эпидемиология

Возбудителем является вирус простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-1 и ВПГ-2) семейства Orthoherpesviridae; геном представлен двуспиральной ДНК. Биологические свойства вируса — пантропизм, способность к пожизненной персистенции и латенции в организме человека.

ПГ является антропонозным заболеванием; в большинстве случаев инфицирование происходит в детском возрасте. Основные пути передачи — воздушно-капельный и контактно-бытовой, возможна аутоинокуляция. Входные ворота — кожа губ, слизистая оболочка полости рта, реже носоглотки, конъюнктива; риск заражения повышается при травматизации кожи и слизистых оболочек.

2.3 Классификация

Типичные формы по клиническим проявлениям и локализации

1. поражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта: стоматит, гингивит, эзофагит;
2. поражение кожи: герпес губ, крыльев носа, лица, рук, ягодиц;
3. поражение половых органов и урогенитального тракта;
4. поражение глаз (офтальмогерпес);
5. поражение нервной системы: менингит, энцефалит, менингоэнцефалит, неврит, поражение бульбарных нервов;
6. поражение внутренних органов, генерализованный ПГ.

Атипичные формы: абортивная, отёчная, зостериформная, язвенно-некротическая, геморрагическая, эрозивно-язвенная и др.

Степень тяжести

1. лёгкая — **1–3 рецидива в год**;
2. средней тяжести — **4–6 рецидивов в год**;
3. тяжёлая — **6 и более рецидивов в год**.

2.4 Клиническая картина

Первичный ПГ возникает после первого контакта с вирусом, чаще в детском возрасте; характеризуется выраженной симптоматикой и может сопровождаться стадией предвестников.

Жалобы

1. жжение, покалывание, боль в области высыпаний;
2. усталость, слабость, недомогание, головная боль, нарушение сна, парестезии;
3. повышение температуры тела, болезненность и увеличение регионарных лимфатических узлов.

Продолжительность первичного эпизода — **10–14 и более дней**, рецидива — в среднем **5–6 дней**.

Рецидивирующий ПГ отличается меньшей интенсивностью и продолжительностью проявлений; частота рецидивов — от 1–3 до 6–12 и более в год. Высыпания фиксированы на месте внедрения вируса («locus minoris»), им предшествуют жжение, покалывание, зуд.

Элементы высыпаний

1. сгруппированные пузырьки 1,5–2 мм на фоне эритемы, содержимое мутнеет, иногда становится геморрагическим;
2. после вскрытия — болезненные эрозии с фестончатыми очертаниями и гиперемированным основанием;
3. регионарный лимфаденит с умеренно болезненными лимфатическими узлами;
4. после эпителизации — медленно разрешающаяся гиперпигментация.

Герпетический стоматит — поражение слизистой оболочки полости рта с пузырьковыми высыпаниями и эрозиями, повышением температуры тела и головной болью. Инкубационный период — **1–8 дней**.

1. высыпания на языке, внутренней поверхности губ, дёснах, щеках, твёрдом и мягком нёбе;
2. болезненные полициклические эрозии, гингивит с кровоточивостью дёсен, обильная вязкая саливация;
3. подчелюстные лимфатические узлы увеличены и болезненны, при среднетяжёлой и тяжёлой форме — двусторонний подчелюстной и шейный лимфаденит;
4. жалобы на боль при приёме пищи и неприятный запах изо рта.

При герпетическом везикулярном дерматите хроническое рецидивирующее поражение захватывает любой участок кожи и слизистых оболочек вне генитальной локализации: мелкие сгруппированные пузырьки на гиперемированном отёчном основании, после вскрытия — эрозии с полициклическими краями; возможны зуд, жжение, боль.

Герпетический энцефалит

1. начинается остро с высокой температуры, слабости, головной боли, тошноты и рвоты, респираторных симптомов;
2. нарушение сознания по типу спутанности, оглушённости, дезориентации у большинства больных, у 12% — до комы;
3. в 95% случаев возбудителем является ВПГ-1.

У нелеченых пациентов энцефалит быстро прогрессирует с отёком мозга и приводит к смерти **в течение 7–14 дней**; без своевременного противовирусного лечения летальность может превышать 50%.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

У пациентов с типичной манифестной локализованной формой ПГ диагноз устанавливается на основании клинической картины.

3.2 Жалобы и анамнез

Что уточнить

1. эпизоды высыпаний с повторяющейся локализацией: красная кайма губ, кожа вокруг рта, крылья носа, полость рта, кисти;
2. зуд, жжение, покалывание, боль в области высыпаний;
3. симптомы интоксикации и подъём температуры;
4. болезненность и увеличение регионарных лимфатических узлов.

3.3 Физикальное обследование

При осмотре оценивают

1. общее состояние и системные проявления;
2. цвет, влажность и отёчность кожи и видимых слизистых оболочек;
3. характер высыпаний — везикулы, эрозии, язвы, их локализацию, величину и глубину;
4. болезненность и интенсивность слюноотделения при поражении полости рта.

Всем пациентам выполняются осмотр и пальпация лимфатических узлов головы, шеи и паховой области с определением их болезненности и размеров.

3.4 Лабораторные исследования

Лабораторное подтверждение необходимо

1. при атипичных, стёртых, торпидных и бессимптомных формах, в том числе при иммуносупрессии;
2. для дифференциальной диагностики;
3. для изменения тактики лечения.

Выявление ДНК ВПГ-1/-2 методом ПЦР в соскобах со слизистой оболочки полости рта, в отделяемом везикул и эрозивно-язвенных поражений кожи является методом выбора.

Наибольшее диагностическое значение имеет выявление IgM к ВПГ-1/-2 — признак острого заболевания, реинфекции или реактивации; при типичном течении IgM выявляются редко (3–6%). Лабораторным критерием, подтверждающим диагноз, является нарастание титра IgG **в 4 и более раз** за 10–14 дней (метод парных сывороток).

При неврологической симптоматике ПЦР спинномозговой жидкости является «золотым» стандартом диагностики герпетического энцефалита и менингита (чувствительность 98%, специфичность 100%). При отрицательном результате и сохраняющихся клинических или нейровизуализационных признаках исследование повторяют **через 3–7 дней**.

3.5 Инструментальные исследования

При частоте рецидивов **не более 2 раз в год** и типичной локализованной форме инструментальные исследования не рекомендуются.

При тяжёлом, диссеминированном течении или поражении ЦНС выполняются спинномозговая пункция и КТ или МРТ головного мозга. Противопоказаниями к люмбальной пункции являются прогрессирующий отёк головного мозга, дислокационный синдром, геморрагический синдром; при повышенном внутричерепном давлении ацикловир начинают до пункции.

При энцефалите очаги некроза чаще выявляются в лобно-височной области **с 5–7-го дня** заболевания; нейровизуализация не достаточна для этиологического диагноза.

3.6 Консультации специалистов

1. **невролог** — при поражении ЦНС, коморбидной патологии, торпидности терапии
2. **офтальмолог** — при поражении органов зрения, для оценки внутричерепной гипертензии
3. **стоматолог-терапевт** — при патологии полости рта
4. **аллерголог-иммунолог** — при частоте рецидивов **более 6 раз в год**
5. **анестезиолог-реаниматолог** — при жизнеугрожающих состояниях, прогрессировании общемозговой и очаговой симптоматики

При часто рецидивирующем ПГ, в том числе с язвенно-некротическими проявлениями, устойчивом к терапии, и при энцефалите показано обследование на ВИЧ-инфекцию: ПГ рассматривается как СПИД-индикаторное заболевание.

---

4. Лечение

4.1 Противовирусная терапия

Пациентам с первичным эпизодом или рецидивом ПГ назначаются противовирусные препараты системного действия; терапию начинают на ранних сроках, до получения результатов вирусологического исследования, эмпирически.

Препараты группы нуклеозидов и нуклеотидов начинают при первых признаках поражения кожи и слизистых оболочек (зуд, жжение, покраснение); при рецидивирующем герпесе — желательно в продромальном периоде или в самом начале рецидива.

Первичный клинический эпизод — внутрь

1. ацикловир: 200 мг 5 раз в сутки, **7–10 дней**;
2. валацикловир: 500 мг 2 раза в сутки, **7–10 дней**;
3. #фамцикловир: 250 мг 3 раза в сутки, **7–10 дней**.

Рецидив — внутрь

1. ацикловир: 200 мг 5 раз в сутки, **5 дней**;
2. валацикловир: 500 мг 2 раза в сутки, **5 дней**;
3. фамцикловир: 250 мг 3 раза в сутки, **5 дней**.

При тяжёлом или диссеминированном течении, поражении ЦНС, судорогах или поражении внутренних органов назначается ацикловир внутривенно — медленной инфузией **в течение 1 часа**.

1. ВПГ-инфекция, кроме энцефалита: 5 мг/кг каждые 8 часов, как правило, **5 дней**; при тяжёлых инфекциях — 5–10 мг/кг каждые 8 часов до разрешения или **до 14–21 дня** с переходом на приём внутрь;
1. герпетический энцефалит: 10 мг/кг каждые 8 часов **14 дней**, в ряде случаев **до 21 дня**; доза снижается при почечной недостаточности.

Супрессивная терапия

Показана при рецидивах **более 6 раз в год**, «монотонном» или тяжёлом течении, низкой эффективности эпизодической терапии.

1. #ацикловир: 400 мг 2 раза в сутки;
2. валацикловир: 500 мг 1 или 2 раза в сутки; при 10 и более рецидивах в год — 1 г в сутки;
3. фамцикловир: 250 мг 2 раза в сутки.

Перед супрессивной терапией необходимо ПЦР-подтверждение ВПГ-инфекции; после курса делают перерыв для оценки течения. Эффективность оценивают как минимум по двум рецидивам.

При часто рецидивирующем ПГ в анамнезе после манипуляций, нарушающих целостность кожи и слизистых оболочек или связанных с воздействием на чувствительные нервные волокна, проводится превентивная терапия **в течение 10 дней**.

1. #ацикловир: 200 мг 5 раз в сутки;
2. валацикловир: 500 мг 1 раз в сутки;
3. фамцикловир: 250 мг 2 раза в сутки.

При низкой эффективности противовирусных препаратов или противопоказаниях к ним в комплексной терапии рецидивирующего и осложнённого ПГ применяют препараты интерферонов.

4.2 Местное и симптоматическое лечение

Местная терапия дополняет, но не заменяет системную противовирусную.

1. противовирусные мази и кремы, например ацикловир, мазь 5%;
2. антисептики — для профилактики вторичной инфекции;
3. при стоматите — полоскания, протеолитические ферменты, препараты для заживления раневой поверхности.

1. **лихорадка выше 38,0 °C** — производные пропионовой кислоты, анилиды, производные уксусной кислоты
2. **боль при поражении полости рта** — местное обезболивание перед едой, например лидокаин, гель 2%
3. **зуд, жжение, аллергическая реакция** — антигистаминные средства системного действия: хлоропирамин 75–100 мг в сутки, курс **до 5 дней**

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

У пациентов с рецидивирующим ПГ выявляют факторы риска частого рецидивирования.

При часто рецидивирующем (**более 6 раз в год**), тяжёлом или «монотонном» течении, низкой эффективности или противопоказаниях к супрессивной терапии проводится специфическая иммунная терапия вакциной для профилактики герпетических инфекций — только в стадии ремиссии, **не ранее чем через 10 дней** после исчезновения проявлений.

Курс при поражении кожи и слизистых оболочек — 5 внутрикожных инъекций по 0,2 мл с интервалом 7 дней.

Пациенты, перенёсшие тяжёлые и осложнённые формы ПГ или ПГ с поражением нервной системы, после выписки подлежат диспансерному наблюдению.

5.2 Показания к госпитализации

Лёгкие, среднетяжёлые и неосложнённые формы ПГ лечат в амбулаторных условиях; при безуспешности лечения или невозможности его проведения рассматривается госпитализация.

Показания к госпитализации

1. тяжёлая форма ПГ;
2. осложнённая форма;
3. диссеминированная форма.

Тактику ведения пересматривают

1. при новых высыпаниях или признаках генерализации;
2. при осложнениях со стороны ЦНС: изменение психического состояния, сонливость, судороги, спутанность сознания, паралич;
3. при вторичной бактериальной инфекции, в том числе высокой температуре **более 3 дней**.

Критерии выписки

1. улучшение клинической картины;
2. отсутствие угрозы жизни и здоровью пациента.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Простой герпес (ПГ) у взрослых»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 16.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	492_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского; Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Классификация по тяжести (раздел 1.5.7) относит 6 рецидивов в год одновременно к средней («4–6») и тяжёлой («6 и более») степени, тогда как показания к супрессивной терапии, вакцинации и консультации иммунолога сформулированы как «более 6 раз в год».

Клинические рекомендации

РСВ-инфекция у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B97.4** — Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках **J00** — Острый назофарингит (насморк) **J02.8** — Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями **J04.1** — Острый трахеит **J04.2** — Острый ларинготрахеит **J06.0** — Острый ларингофарингит **J20.5** — Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом **J21.0** — Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 12.09.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Общественная организация "Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины"; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/943_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Острая вирусная инфекция с умеренной лихорадкой и интоксикацией и частым поражением нижних дыхательных путей: бронхит, бронхиолит, пневмония, бронхиальная обструкция, дыхательная недостаточность.
- При рините, особенно с лихорадкой, показана отоскопия: острый средний отит встречается часто и развивается преимущественно в первые дни. При подозрении на отит или синусит необходим осмотр оториноларинголога.
- Тяжесть определяет дыхательная недостаточность, а не температура. При сатурации **ниже 92%**, нарастании дыхательной недостаточности или судорогах необходим осмотр анестезиолога-реаниматолога.
- Лёгкую и среднетяжёлую форму лечат по общим принципам лечения ОРВИ. При неосложнённом бронхиолите антибиотики, ингаляционные бронхолитики и кортикостероиды рутинно не назначают.
- Госпитализации подлежат дети с поражением нижних дыхательных путей. При бронхиолите, пневмонии, дыхательной недостаточности и генерализованной форме госпитализация проводится в инфекционный стационар с отделением реанимации и интенсивной терапии.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острое респираторное вирусное заболевание с катаральным синдромом и преимущественным поражением нижних дыхательных путей, умеренной лихорадкой и интоксикацией; часто развиваются бронхит, бронхиолит и пневмония, нередко острая бронхиальная обструкция и дыхательная недостаточность.

2.2 Этиология и патогенез

Возбудителем является РНК-содержащий вирус семейства Paramyxoviridae, рода Pneumovirus. Вирус относится к одному серотипу; подтипы А и В по тяжести не различаются.

Наибольшие изменения наблюдаются в бронхах среднего и мелкого калибра, бронхиолах и альвеолах: просвет заполняют слущенный эпителий и экссудат, клапанный механизм задерживает воздух, при полной обструкции — ателектазы. Отёк слизистой мелких бронхов у ребёнка всего **на 1 мм** повышает сопротивление потоку **более чем на 50%**.

Инфекция высоко контагиозна, инкубационный период составляет **3–5 дней**, до 8. Вирус передаётся воздушно-капельным и контактным путём. Иммунитет нестойкий: повторно болеют даже в течение одного сезона, реинфекция легче. Вирус выделяется в среднем **10–14 дней**.

Группа риска тяжёлого течения

1. недоношенные с массой тела **2,5 кг и меньше**;
2. бронхолёгочная дисплазия;
3. врождённые пороки сердца;
4. после трансплантации органов, системные и хронические заболевания.

2.3 Классификация

1. по тяжести: лёгкая, среднетяжёлая, тяжёлая;
2. по течению: гладкое, негладкое (осложнённое);
3. по симптомам: типичная, атипичная (бессимптомная);
4. по локализации: ринит, фарингит, трахеит, ларингит, бронхит, бронхиолит, пневмония и их сочетания.

2.4 Клиническая картина

Начало острое или постепенное, тяжесть нарастает. Температура субфебрильная или нормальная, реже фебрильная; интоксикация умеренная. Катаральные явления умеренные: необильный серозный ринит и фарингит, возможен ларинготрахеит.

У детей **старше 6 лет** и взрослых обычно лёгкое течение с поражением только верхних дыхательных путей.

У детей раннего возраста начинается с ринофарингита, **на 2–3-й день** — бронхит и бронхиолит с бронхиальной обструкцией: экспираторная одышка, втяжение межреберий, приступообразный мучительный кашель.

Аускультация

1. бронхит: на фоне жёсткого дыхания сухие свистящие, у части — влажные мелко- и среднепузырчатые хрипы;
2. бронхиолит: обильные мелкопузырчатые влажные и крепитирующие хрипы, коробочный звук.

Степени тяжести

Тяжесть	Признаки
лёгкая	температура **не выше 38,5 °C**, интоксикация и катар слабые; нижние дыхательные пути обычно не поражены; чаще дети **старше 3 лет**
среднетяжёлая	форма преобладает в 86–90% случаев, преимущественно у детей первых лет жизни. Проявляется ринитом, фарингитом, ларингитом и трахеитом (возможен стенозирующий ларинготрахеит), а также бронхитом с обструкцией или бронхиолитом с дыхательной недостаточностью I–II степени; обратное развитие **через 5–7 дней**
тяжёлая	чаще первый год жизни: вялость, шумное свистящее дыхание, бледность, цианоз, одышка **более 80 в минуту** с участием вспомогательных мышц; обструктивный бронхит, бронхиолит или бронхопневмония с дыхательной недостаточностью II–III; у недоношенных возможна гипотермия

При тяжёлой форме сатурация **ниже 90%**; возможны брадипноэ, апноэ, кардиопульмональная синкопа. Тяжесть поражения нижних дыхательных путей не соответствует выраженности лихорадки: ориентируются на дыхательную недостаточность.

Степени дыхательной недостаточности

Степень	Признаки
I	одышка, тахикардия, раздувание крыльев носа при значительной нагрузке
II	одышка и тахикардия при небольшой нагрузке, небольшой цианоз губ, втяжение межреберий и подреберий
III	одышка и тахипноэ в покое, разлитой цианоз, вспомогательные мышцы; SaO_2 **ниже 90%**, PaO_2 **ниже 60 мм рт. ст.**; возможны гипоксическая энцефалопатия и кардиопульмональная синкопа
IV	гипоксемическая кома: сознания нет, дыхание аритмичное, поверхностное, апноэ

3. Диагностика

Диагноз РСВ-инфекции устанавливается после этиологической диагностики (ПЦР, иммуноферментный анализ), без неё диагноз остаётся синдромальным. Лабораторную диагностику, как правило, проводят при госпитализации или по эпидемическим показаниям.

Основные методы: ОТ-ПЦР на РНК вируса, иммунофлюоресценция и иммунохроматография на вирусные частицы, иммуноферментный анализ на IgM и IgG.

3.1 Оценка дыхательной недостаточности

Показания

1. все пациенты с РСВ-инфекцией.

Диагностические признаки

1. участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания;
2. частота дыхания.

3.2 ПЦР мазка из носоглотки на РНК РСВ

Показания

1. подозрение на РСВ-инфекцию: однократное исследование.

Метод достоверен на ранних сроках заболевания.

Специфичность и чувствительность ПЦР составляют 100%.

3.3 ПЦР мазков из носо- и ротоглотки на другие респираторные вирусы

Показания

1. дифференциальная диагностика с другими ОРВИ; возможна смешанная инфекция.

Исследуемые вирусы

1. вирусы гриппа и парагриппа;
2. риновирусы, аденовирус, коронавирусы, бокавирус, метапневмовирус;
3. SARS-CoV-2.

3.4 Антитела IgM и IgG к РСВ (иммуноферментный анализ)

Показания

1. ПЦР невозможна;
2. поздние сроки заболевания.

Диагностические признаки

1. IgM появляются **на 4–5-й день**;
2. нарастание IgG **в 2–4 раза** в парных сыворотках.

Однократно выявленные IgG не свидетельствуют об острой инфекции. От 10 до 30% переболевших остаются серонегативными.

3.5 Иммунохроматографический экспресс-тест мазка из носоглотки

Показания

1. ПЦР и иммуноферментный анализ невозможны.

Результат готов **через 15–30 минут**. Отрицательный результат подтверждают более чувствительным методом.

Чувствительность экспресс-теста составляет 75–95%.

Реакция иммунофлюоресценции мазка из носоглотки — если молекулярно-генетическое исследование невозможно.

Иммуноцитохимия мазков-соскобов из ротоглотки — если молекулярно-генетическое исследование невозможно.

3.6 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. среднетяжёлая и тяжёлая форма;
2. длительное сохранение повышенной температуры тела.

Диагностические признаки

1. для вирусной инфекции типичны лейкопения или нормоцитоз с лимфоцитозом и моноцитозом;
2. возможны изменения, сходные с бактериальной инфекцией.

3.7 Общий (клинический) анализ мочи

Показания

1. среднетяжёлая и тяжёлая форма.

При лихорадке на фоне бронхиолита возможны «токсическая почка» или инфекция мочевых путей.

3.8 С-реактивный белок и прокальцитонин

Показания

1. подозрение на бактериальную инфекцию и сепсис.

Посев крови и мочи, определение СРБ и прокальцитонина необходимы при высокой лихорадке в сочетании со SpO_2 **ниже 92%** и апноэ. В остальных случаях бактериемия при бронхиолите крайне маловероятна.

3.9 Пульсоксиметрия

Показания

1. поражение нижних дыхательных путей.

Результат определяет степень тяжести, потребность в кислородной поддержке и маршрутизацию пациента.

3.10 Электрокардиография

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое поражение нижних дыхательных путей;
2. фоновая патология сердца;
3. подозрение на нарушения ритма и проводимости или миокардит при симптомах дыхательной недостаточности, в том числе SaO_2 **ниже 95%**.

3.11 Рентгенография органов грудной клетки

Показания: подозрение на пневмонию

1. температура **выше 38 °C** **более 3 дней**;
2. токсикоз;
3. укорочение перкуторного звука;
4. асимметрия хрипов.

Рутинная рентгенография при бронхиолите не рекомендуется: ателектазы принимают за пневмонию и необоснованно назначают антибиотики.

При тяжёлом течении, если рентгенографии недостаточно, выполняется КТ органов грудной полости.

3.12 Осмотр оториноларинголога

Показания

1. подозрение на отит или синусит.

При рините, особенно с лихорадкой, показана отоскопия: острый средний отит встречается часто, ЛОР-осложнения развиваются преимущественно в первые дни, но возможны и позже.

3.13 Осмотр анестезиолога-реаниматолога

Показания

1. нарастание дыхательной недостаточности;
2. сатурация **ниже 92%**;
3. судороги.

Цель осмотра: решение о переводе в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

3.14 Дифференциальная диагностика бронхиальной обструкции

Дифференциальная диагностика

Диагноз	В пользу диагноза
острый бронхиолит	первый эпизод обструкции **до 2 лет**, сезон вирусов, катар, выраженная одышка, диффузная крепитация и хрипы, слабый ответ на бронхолитики
обструктивный бронхит	обструкция только при простуде, нет атопии у ребёнка и в семье, возможен ответ на бронхолитики
бронхиальная астма	первый эпизод **после 1 года**, аллергены и другие триггеры, атопия, повторные эпизоды и вне простуды, хороший ответ на бронхолитики и ингаляционные ГКС
инородное тело дыхательных путей	внезапное начало во время еды или игры с мелкими предметами, хрипы с одной стороны, нет ответа на бронхолитики
пневмония	лихорадка, влажный кашель, локальные хрипы, притупление, инфильтрат на рентгенограмме, лейкоцитоз, повышение СРБ
муковисцидоз	хроническая инфекция лёгких, кишечные проявления, полипы носа, солёная кожа, отставание в развитии
сердечная недостаточность	пороки сердца со сбросом крови слева направо (дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородки), миокардит, кардиомиопатия
нейроэндокринная клеточная гиперплазия младенцев	начало в грудном возрасте, чаще в 3–4 месяца; персистирующее тахипноэ, одышка, необъяснимая дыхательная недостаточность со снижением SpO_2; задержка прибавки массы; крепитация больше над передней поверхностью грудной клетки; нет лихорадки, свистящие хрипы редки; «матовое стекло» в средней доле и язычковых сегментах на КТ

Диагноз	В пользу диагноза
коклюш	приступообразный кашель с репризами и рвотой, апноэ, нет лихорадки и катара, лимфоцитарный лейкоцитоз

4. Лечение

Лечение лёгкой и среднетяжёлой формы без осложнений проводится амбулаторно по общим принципам лечения ОРВИ. Специфической этиотропной терапии нет, лечение начинают с первых симптомов.

4.1 Противовирусная терапия

Детям раннего возраста, в том числе с рождения, при поражении нижних дыхательных путей назначают интерферон альфа-2b. Наиболее эффективен **в первые 3 суток**, при бронхиолите играет вспомогательную роль.

Лекарственные формы интерферона

1. местно: спрей, капли в нос, гель, мазь;
2. системно: свечи.

4.2 Бронхиолит

При неосложнённом бронхиолите антибиотики не назначают.

При дегидратации на фоне одышки и поражения нижних дыхательных путей проводится регидратация:

1. прежде всего перорально;
2. при невозможности через назогастральный зонд;
3. внутривенно при эксикозе II–III степени: 0,9% натрия хлорид или натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид), **не более 20 мл/кг/сут** из-за риска отёка лёгких.

Рутинно не применяют при бронхиолите

1. ингаляционные бронхолитики (адреномиметики);
2. ингаляционный будесонид;
3. системные кортикостероиды.

Убедительных данных об их эффективности нет.

Для системных кортикостероидов УУР В, УДД 2.

4.3 Симптоматическая терапия

При температуре **выше 38,5 °C** применяют парацетамол или ибупрофен по инструкции. При судорогах в анамнезе или на фоне болезни температуру снижают и при меньших значениях.

Детям первого года при субфебрилитете **37,5–38,5 °C** с нарушением самочувствия и сна применяют гомеопатический препарат Вибуркол в ректальных свечах по инструкции.

4.4 Оксигенотерапия

При бронхиолите или дыхательной недостаточности назначают увлажнённый кислород через носовые канюли или маску при SaO_2 **ниже 92–94%** до устойчивых **95%**. При тяжёлом бронхиолите, выраженной гипоксии, апноэ применяют CPAP.

Амбулаторно применяют местные средства по симптомам: полоскания, тёплое питьё, ингаляции, таблетки для рассасывания, физиотерапия.

Хирургическое лечение не показано.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Амбулаторное лечение показано детям с лёгкой и среднетяжёлой формой без осложнений. Госпитализации подлежат дети с поражением нижних дыхательных путей.

Бронхиолит, дыхательная недостаточность, пневмония или генерализованная форма РСВ-инфекции требуют госпитализации в инфекционный стационар с отделением реанимации и интенсивной терапии.

Показания к госпитализации

1. среднетяжёлая и тяжёлая форма, особенно с осложнениями или обострением сопутствующих болезней у детей первых 2 лет, а у старших — с обострением или угрозой обострения болезней сердца и лёгких;
2. бронхиолит или пневмония с обструкцией у новорождённых, особенно недоношенных **2,5 кг и меньше**;
3. гемодинамическая нестабильность: холодные конечности, цианоз, мраморность, коллапс, кома;
4. отягощённый преморбидный фон: пороки лёгких, бронхолёгочная дисплазия, пороки сердца, муковисцидоз, бронхиальная астма, трансплантация.

Чем младше ребёнок, тем шире показания: состояние может ухудшиться катастрофически быстро.

Критерии выписки

1. стабилизация состояния;
2. купирование признаков дыхательной недостаточности;
3. купирование интоксикации.

5.2 Факторы риска тяжёлого бронхиолита

1. мужской пол;
2. недоношенность, масса при рождении **менее 2500 г**;
3. возраст **до 3–6 месяцев**, масса **менее 5 кг**;
4. врождённая пневмония, аспирация мекония, ИВЛ в неонатальном периоде;
5. скученность, старшие братья и сёстры в детских коллективах, пассивное курение;
6. бронхолёгочная дисплазия, муковисцидоз, пороки дыхательных путей;
7. тяжёлые поражения ЦНС, синдром Дауна, нервно-мышечные болезни, аспирация пищи;
8. пороки сердца с сердечной недостаточностью или лёгочной гипертензией;
9. иммунодефициты.

5.3 Профилактика

Неспецифическая профилактика такая же, как при ОРВИ: ограничение контактов, маски, мытьё рук, в стационаре профилактика внутрибольничного заражения. Грудное вскармливание **не менее 6 месяцев** защищает от РСВ.

Показания к иммунопрофилактике паливизумабом

1. дети **до 6 месяцев**, рождённые на **35-й неделе** и раньше;
2. дети **до 2 лет**, лечившиеся по поводу бронхолёгочной дисплазии в последние 6 месяцев;
3. дети **до 2 лет** с гемодинамически значимыми пороками сердца.

Дозы соответствуют инструкции.

Пассивная иммунопрофилактика по индивидуальным показаниям

1. иммунодефициты;
2. тяжёлые нервно-мышечные заболевания;
3. врождённые пороки развития;
4. орфанные заболевания с генетической патологией, затрагивающей дыхательную функцию.

Специальной реабилитации нет: без поражения мелких бронхов дети восстанавливаются сами; при осложнениях — реабилитация по осложнению.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 12.09.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2028 года
Код в рубрикаторе	943_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Инкубационный период указан по-разному: 3–5 (до 8) дней в разделах 1.3 и 1.6, 2–4 дня в комментарии раздела 2.3. Длительность выделения вируса — 10–14 дней (раздел 1.3) и 5–7 дней (раздел 2.3).
- Гомеопатический Вибуркол рекомендован детям первого года (УУР С, УДД 3), тогда как КР «ОРВИ у детей» гомеопатию для лечения ОРВИ не рекомендуют.

Клинические рекомендации

Рак гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C32** — Злокачественное новообразование гортани **D38.0** — Гортани
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.08.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/475_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рак гортани является злокачественной опухолью, развивающейся из элементов неороговевающего эпителия гортани. Основными симптомами являются изменение тембра голоса, осиплость, поперхивания.
- Рак гортани следует заподозрить при следующих симптомах:
  1. стойкая осиплость;
  2. кашель и боль в горле, не проходящие на фоне антибактериального и противовоспалительного лечения;
  3. затруднение дыхания;
  4. увеличение шейных лимфатических узлов, образования на шее.
- Предопухолевые заболевания:
  1. хронический гиперпластический ларингит;
  2. пахидермия, лейкоплакия, дисплазия и гиперкератоз слизистой оболочки гортани;
  3. полипы голосовых складок;
  4. папилломатоз гортани.
- Всем пациентам с подозрением на рак гортани показана фиброларингоскопия с биопсией; при повторных неинформативных биопсиях выполняется видеофиброларингоскопия с биопсией под общей анестезией.
- При подозрении на онкологическое заболевание пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи (первичный онкологический кабинет); консультация проводится **не позднее 5 рабочих дней** с даты направления.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. **надскладочный отдел**: гортанная поверхность надгортанника (включая верхушку), черпалонадгортанные связки, черпаловидные хрящи и межчерпаловидная область, часть надгортанника ниже подъязычной кости, вестибулярные складки, гортанные желудочки;
2. **складочный отдел**: голосовые складки, передняя и задняя комиссуры;
3. **подскладочный отдел**: от нижней поверхности голосовых складок до уровня первого кольца трахеи.

Голосовой протез представляет собой клапанное устройство для восстановления голоса, имплантируемое при трахеопищеводном шунтировании. Электрогортань является вибрирующим аппаратом, прикладываемым к подбородку; голос при этом металлический, без тембровой и эмоциональной окраски.

2.2 Этиология и эпидемиология

Факторы риска: длительное курение, алкоголь, запылённость (текстильное производство), канцерогены (нефть и продукты перегонки, бензол, фенольные смолы, асбест). Высокий риск озлокачествления имеют папилломы (рак, ассоциированный с ВПЧ), рецидивирующий папилломатоз, пахидермия, дискератоз, хронические ларингиты.

Заболеваемость в России в 2019 г. составила 31,1 на 100 тыс. населения, летальность 7,2%.

2.3 Клиническая картина

1. **вестибулярный (надскладочный) отдел**: на ранних стадиях опухоль может протекать бессимптомно; пациенты жалуются на парестезию, сухость, ощущение инородного тела, неудобство при глотании; позже присоединяются боль при глотании с иррадиацией в ухо, дисфагия, гнилостный запах, кровохарканье;
2. **голосовой (складочный) отдел**: симптомы появляются рано (охриплость, кашель, реже кровохарканье); при прогрессировании развиваются стеноз, боль с иррадиацией в ухо, гнилостный запах;
3. **подскладочный отдел**: раннее затруднение дыхания.

2.4 Классификация TNM (8-е издание AJCC)

Символ T: складочный отдел гортани

T	Складочный отдел
T1	опухоль ограничена голосовыми связками, подвижность сохранена (может быть вовлечена передняя или задняя комиссура); T1a: одна связка, T1b: обе
T2	распространение на надсвязочную и (или) подсвязочную области с нарушением подвижности голосовых связок
T3	ограничена гортанью с фиксацией голосовых связок и (или) прорастанием в надсвязочное пространство, небольшой эрозией щитовидного хряща
T4a / T4b	T4a: прорастание в щитовидный хрящ или ткани вокруг гортани (трахея, мягкие ткани шеи, мышцы языка, щитовидная железа, пищевод); T4b: предпозвоночное пространство, средостение, оболочка сонной артерии

Символ T: надскладочный отдел гортани

T	Надскладочный отдел
T1	ограничена одной анатомической областью надсвязочной части, подвижность голосовых связок сохранена
T2	несколько анатомических частей надсвязочной или связочной области либо вненадсвязочная часть (корень языка, валлекула, медиальная стенка грушевидного синуса) без фиксации гортани
T3	ограничена гортанью с фиксацией голосовых связок и (или) распространением на преднадгортанную ткань, минимальная эрозия щитовидного хряща

Подскладочный отдел

1. T1: опухоль ограничена подсвязочной частью;
2. T2: распространение на голосовые связки со свободной или ограниченной подвижностью;
3. T3: фиксация связок и (или) эрозия щитовидного хряща;
4. T4a: прорастание в перстневидный или щитовидный хрящ, ткани вокруг гортани.

1. **N1**: метастаз в одном ипсилатеральном лимфоузле до 3 см без экстракапсулярной инвазии (ENE−);
2. **N2**: один ипсилатеральный до 3 см с ENE+ или 3–6 см ENE−; несколько ипсилатеральных; с обеих сторон или контралатеральные до 6 см ENE−;
3. **N3**: более 6 см ENE−; любой метастаз с ENE+, кроме N2a.

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
0	Tis N0 M0

Стадия	TNM
I	T1 N0 M0
II	T2 N0 M0
III	T3 N0 M0; T1–T3 N1 M0
IVA	T1–T3 N2 M0; T4 N0–N2 M0
IVB	T4b, любая N, M0; любая T, N3, M0
IVC	любая T, любая N, M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза;
2. физикального обследования: осмотр, пальпация образования, прилежащих тканей и регионарных лимфоузлов;
3. цитологического исследования соскоба, мазков, пунктата опухоли и лимфоузлов;
4. патологоанатомического исследования биопсийного материала;
5. инструментального обследования: фиброларингоскопия, пункция узлов шеи под УЗИ, КТ или МРТ, ПЭТ-КТ.

3.2 Жалобы и анамнез

Симптомы, на которые обращают внимание

1. стойкое нарушение голоса (осиплость), реже кашель;
2. затруднение дыхания при перекрытии просвета гортани;
3. постоянный кашель и боль в горле, не проходящие на фоне антибактериального и противовоспалительного лечения;
4. увеличение шейных лимфатических узлов, образования на шее.

3.3 Физикальное обследование

Признаки при осмотре

1. изменение контуров шеи;
2. увеличение регионарных лимфоузлов;
3. изменение подвижности и ширины остова гортани.

3.4 Фиброларингоскопия с биопсией

Всем пациентам с подозрением на рак гортани показана фиброларингоскопия с биопсией (патологоанатомическое исследование) и цитологическим исследованием отпечатков и мазков для оценки распространённости и верификации опухоли.

При повторных неинформативных биопсиях и клинико-рентгенологических данных о злокачественном процессе выполняется видеофиброларингоскопия с биопсией под общей анестезией.

3.5 УЗИ шеи, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ

Всем пациентам с раком гортани показано УЗИ лимфатических узлов шеи с пункцией подозрительных узлов.

При распространённом раке с поражением регионарных лимфатических узлов выполняется КТ органов грудной полости для выявления отдалённых метастазов.

При стадиях III–IV показана ПЭТ-КТ с ФДГ для исключения отдалённых метастазов и оценки эффекта лечения, в том числе регрессии регионарных метастазов после лучевой или химиолучевой терапии.

При подозрении на распространение на хрящи гортани, основание черепа, магистральные сосуды показана КТ или МРТ мягких тканей шеи и головного мозга с контрастированием; при подозрении на переход опухоли на гортаноглотку или пищевод перед лучевой терапией выполняется МРТ шеи.

3.6 Лабораторные и морфологические исследования

Специфических лабораторных исследований нет. При распространённых стадиях, не предусматривающих только локальное лечение, определяется экспрессия PD-L1 (TPS, CPS).

В заключении по операционному материалу отражают

1. размер и глубину инвазии опухоли;
2. гистологическое строение и степень дифференцировки;
3. лимфоваскулярную и периневральную инвазию;
4. pT и pN с числом исследованных и поражённых лимфоузлов, экстранодальное распространение;
5. состояние краёв резекции.

---

4. Лечение

4.1 Складочный отдел гортани

Лечение рака складочного отдела гортани по стадиям

Стадия	Рекомендованное лечение
Tis (карцинома in situ)	эндоларингеальная резекция (предпочтительно CO_2-лазером) или лучевая терапия (ЛТ)
T1–T2 N0	самостоятельная ЛТ или резекция гортани (эндоскопическая лазерная или открытая)
T1–T2 N+	конкурентная химиолучевая терапия (ХЛТ) или резекция гортани с одно- или двусторонней шейной лимфодиссекцией
T3 N0	конкурентная ХЛТ; индукционная химиотерапия (ХТ) для сохранения органа; ларингэктомия с гемитиреоидэктомией и паратрахеальной лимфодиссекцией
T3 N+	одномоментная ХЛТ; индукционная ХТ с последующей ХЛТ; ларингэктомия с шейной лимфаденэктомией
T4a, любая N	ларингэктомия с тиреоидэктомией, паратрахеальной и шейной лимфодиссекцией; при отказе от операции ХЛТ или индукционная полихимиотерапия (ПХТ) с ХЛТ

При T3 N0 в отдельных случаях, рассматриваемых индивидуально, при отсутствии эрозии щитовидного хряща возможна органосохраняющая трансоральная лазерная или открытая резекция.

После операции тактику определяют по неблагоприятным прогностическим факторам (НПФ). При отсутствии НПФ и pN0 показано динамическое наблюдение.

Тактика после операции по НПФ

1. **R1**: перерезекция, при невозможности ЛТ или ХЛТ;
2. **1 НПФ (периневральная, периваскулярная, перилимфатическая инвазия)**: ЛТ;
3. **2 и более НПФ, pN2**: ХЛТ;
4. **ENE+**: конкурентная ХЛТ.

Тактика после индукционной ХТ и ХЛТ

1. **полная или частичная регрессия после индукционной ХТ**: ЛТ или ХЛТ;
2. **стабилизация или регрессия менее 50%**: хирургическое лечение;
3. **остаточная опухоль после ЛТ или ХЛТ**: хирургическое лечение;
4. **полная регрессия**: динамическое наблюдение.

Эффект ХЛТ оценивают не ранее чем через **2–3 месяца**.

T4b, любая N, неоперабельные регионарные метастазы, M1 или пациенты, не подходящие для операции

1. **ECOG 0–1**: лекарственная терапия (в отдельных случаях ХЛТ) или симптоматическое лечение;
2. **ECOG 2**: лекарственная терапия;
3. **ECOG 3**: симптоматическое лечение.

Шкала оценки тяжести состояния пациента по версии ВОЗ/ECOG

Балл	Описание
0	пациент полностью активен, способен выполнять всё, как и до заболевания (90–100% по шкале Карновского)
1	пациент неспособен выполнять тяжёлую, но может выполнять лёгкую или сидячую работу, например лёгкую домашнюю или канцелярскую (70–80% по шкале Карновского)
2	пациент лечится амбулаторно, способен к самообслуживанию, но не может выполнять работу; более 50% времени бодрствования проводит активно, в вертикальном положении (50–60% по шкале Карновского)
3	пациент способен лишь к ограниченному самообслуживанию, проводит в кресле или постели более 50% времени бодрствования (30–40% по шкале Карновского)
4	инвалид, совершенно не способен к самообслуживанию, прикован к креслу или постели (10–20% по шкале Карновского)
5	смерть

4.2 Надскладочный отдел гортани

Лечение рака надскладочного отдела гортани по стадиям

Стадия	Рекомендованное лечение
T1–T2 N0–1	резекция гортани (эндоскопическая или открытая) с одно- или двусторонней шейной лимфодиссекцией; при N0 также самостоятельная ЛТ
T1–T2 N2–3	одномоментная ХЛТ, индукционная ХТ с ХЛТ или резекция гортани с шейной лимфодиссекцией
T3 N0–3	одномоментная ХЛТ или индукционная ХТ с ХЛТ; ларингэктомия с тиреоидэктомией и шейной лимфодиссекцией
T4a N0–3	ларингэктомия с тиреоидэктомией и шейной лимфодиссекцией с послеоперационной ХЛТ; при отказе от операции ХЛТ или индукционная ПХТ с ХЛТ

При раке надскладочного отдела без клинических признаков поражения лимфоузлов всем рекомендуется профилактическая одно- или двусторонняя шейная лимфодиссекция II–IV уровней.

Удаление узлов II–V уровней

1. метастазы в лимфоузлах IV или V уровня;
2. регионарный метастаз более 6 см;
3. множественные метастазы более 3 см;
4. экстракапсулярное распространение;
5. регионарный рецидив.

Локальный рецидив

1. **рецидив без предшествующей ЛТ**: операция при резектабельности; при ECOG 0–1 ХЛТ или индукционная ХТ с ЛТ; при нерезектабельном рецидиве и ECOG 2 паллиативная ЛТ или лекарственная терапия;
2. **рецидив после ЛТ**: операция при резектабельности с обсуждением повторной ЛТ или ХЛТ;
3. **рецидив с отдалёнными метастазами**: при ECOG 0–1 и ECOG 2 лекарственная терапия, при ECOG 3 симптоматическое лечение.

4.3 Лучевая и лекарственная терапия

Самостоятельная ЛТ: на опухоль и регионарные метастазы 66–70 Гр (2,0–2,2 Гр за фракцию) **6–7 недель**, на зоны регионарного метастазирования 44–63 Гр. При T1N0M0 голосового отдела возможно гипофракционирование 50–55 Гр.

При ХЛТ суммарная доза составляет 70 Гр за 7 недель. Стандартом является цисплатин 100 мг/м² в 1, 22 и 43-й дни ЛТ. После индукционной ПХТ при плоскоклеточном раке в качестве альтернативы цисплатину целесообразны карбоплатин или цетуксимаб с учётом переносимости ХЛТ и соматического состояния пациента.

Отказ от платиносодержащих схем в пользу цетуксимаба целесообразен также при высоком риске побочных эффектов препаратов платины (СКФ менее 50–60 мл/мин, возраст старше 65 лет, ECOG более 1).

Послеоперационная ЛТ показана при pT3–4 и N0–1, у отдельных пациентов с pT1–2. Интервал после операции составляет **до 6 недель**, **не более 3 месяцев**. Доза при R0 составляет 60 Гр, при R+ 66 Гр.

Показания к послеоперационной ХЛТ

1. прорастание капсулы лимфоузла;
2. положительный край резекции при отказе от реоперации;
3. 2 и более неблагоприятных фактора.

Лекарственная терапия плоскоклеточного рака индивидуализируется: схемы на основе препаратов платины, фторурацила, таксанов и цетуксимаба; иммунотерапия ниволумабом или пембролизумабом (с учётом PD-L1); при ECOG 2 применяется монотерапия. Режимы и дозы приведены в таблице ниже.

Режимы лекарственной терапии плоскоклеточного рака головы и шеи

Режим	Схема проведения
PF + цетуксимаб	Цисплатин 75–100 мг/м² в/в в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м²/сут в/в 96-часовой инфузией в 1–4-й дни, каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза), далее 250 мг/м² в/в еженедельно. После 6 циклов химиотерапия завершается; при отсутствии прогрессирования продолжают поддерживающую терапию цетуксимабом 250 мг/м² в/в еженедельно.

Режим	Схема проведения
DC + цетуксимаб	#Доцетаксел 75 мг/м² в/в в 1-й день + цисплатин 75 мг/м² в/в в 1-й день, каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза) в/в, далее 250 мг/м² в/в еженедельно. После 4 циклов химиотерапия завершается; при отсутствии прогрессирования продолжают поддерживающую терапию цетуксимабом 500 мг/м² в/в 1 раз в 2 недели.
Цисплатин + цетуксимаб	Цисплатин 75–100 мг/м² 1 раз в 3 недели (не более 6–8 введений) + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза) в/в в 1-й день, далее 250 мг/м² в/в еженедельно до прогрессирования или непереносимой токсичности.
Паклитаксел + карбоплатин + цетуксимаб	#Паклитаксел 100 мг/м² в/в + карбоплатин AUC 2,5 в/в в 1-й и 8-й дни + цетуксимаб 400 мг/м² в/в (2-часовая инфузия) в 1-й день 1-го цикла (нагрузочная доза), далее 250 мг/м² в/в (1-часовая инфузия) еженедельно. Длительность цикла 21 день. После 6 циклов при отсутствии прогрессирования продолжают поддерживающую терапию цетуксимабом 250 мг/м² в/в еженедельно.
Паклитаксел + карбоплатин + цетуксимаб [1]	#Паклитаксел 80 мг/м² в/в еженедельно + карбоплатин AUC 2,0 в/в еженедельно + цетуксимаб 400 мг/м² в/в (2-часовая инфузия) в 1-й день 1-го цикла, далее 250 мг/м² в/в еженедельно. После завершения химиотерапии при отсутствии прогрессирования продолжают поддерживающую терапию цетуксимабом 250 мг/м² в/в еженедельно. Количество введений цитостатиков определяется индивидуально.
PF [2]	Цисплатин 75–100 мг/м² в/в в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м²/сут в/в 96-часовой инфузией в 1–4-й дни, каждые 3 недели. Либо карбоплатин AUC 5 в/в в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м² в/в 96-часовой инфузией в 1–4-й дни, каждые 3 недели; общее число циклов 6, при отсутствии токсичности и нарастающей положительной динамике может быть увеличено до 8.
Паклитаксел + карбоплатин [2]	#Паклитаксел 175 мг/м² в/в в 1-й день + карбоплатин AUC 5–6 в/в в 1-й день каждые 3 недели; общее число циклов 6, может быть увеличено до 8. Либо #паклитаксел 60–80 мг/м² в/в еженедельно + карбоплатин AUC 2 в/в еженедельно до прогрессирования или неприемлемой токсичности, но не более 18 недель.
DC [2]	#Доцетаксел 75 мг/м² в/в в 1-й день + цисплатин 75 мг/м² в/в в 1-й день, каждые 3 недели. Общее число циклов 6, при отсутствии токсичности и нарастающей положительной динамике может быть увеличено до 8.
Ниволумаб [3]	3 мг/кг в/в 1 раз в 2 недели, или 240 мг 1 раз в 2 недели, или 480 мг 1 раз в 4 недели; первое введение 60-минутной инфузией, далее 30-минутной, до прогрессирования или неприемлемой токсичности, но не более 2 лет.
Пембролизумаб [4]	200 мг в/в 1 раз в 3 недели (30-минутная инфузия) или 400 мг 1 раз в 6 недель до прогрессирования или неприемлемой токсичности, но не более 2 лет.
PF + пембролизумаб [5]	Пембролизумаб 200 мг + карбоплатин AUC 5 или цисплатин 100 мг/м² + #фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни 1 раз в 3 недели (6 циклов), далее пембролизумаб 200 мг 1 раз в 3 недели или 400 мг 1 раз в 6 недель; не более 35 введений в целом.
Монотерапия при ECOG 2	Цисплатин 60–70 мг/м² в/в 1 раз в 3 недели (целесообразность более 6–8 введений сомнительна); карбоплатин AUC 5–6 в/в 1 раз в 3 недели или AUC 2 в/в еженедельно; #паклитаксел 175 мг/м² в/в 1 раз в 3 недели или 80 мг/м² в/в еженедельно; #доцетаксел 70–75 мг/м² в/в 1 раз в 3 недели; #капецитабин 2000 мг/м² внутрь в 2 приёма в 1–14-й дни, перерыв 1 неделя, или 2000 мг/сут внутрь ежедневно в метрономном режиме; #метотрексат 40 мг/м² в/в еженедельно; цетуксимаб 400 мг/м² в/в (2-часовая инфузия) в 1-й день 1-го курса, далее 250 мг/м² в/в еженедельно. Количество введений определяется индивидуально.

1. [1] для пациентов в общем состоянии по ECOG 2 балла;
2. [2] неоптимальные режимы; применяются только при абсолютных противопоказаниях к анти-EGFR моноклональным антителам;
3. [3] во 2-й и последующих линиях при платинорезистентных опухолях, независимо от уровня экспрессии PD-L1;
4. [4] в 1-й линии при экспрессии PD-L1 CPS ≥ 1; при прогрессировании на фоне или после химиотерапии с препаратами платины при TPS ≥ 50%;
5. [5] в 1-й линии при CPS ≥ 1.

При прогрессировании после цитостатиков, цетуксимаба и иммунного препарата может быть назначен #афатиниб 40 мг в сутки внутрь до прогрессирования или неприемлемой токсичности (эффективность при плоскоклеточном раке головы и шеи оценена только по зарубежным исследованиям).

При местно-распространённом раке оценивают риск кровотечения (изъязвление, близость ветвей сонной артерии, состоявшееся кровотечение); при риске показаны ангиография и суперселективная эмболизация сосудов опухоли.

4.4 Медицинская реабилитация

До операции и в раннем послеоперационном периоде всем пациентам показаны логопедические занятия при дисфагии и обучение речи.

Методы восстановления голоса

1. пищеводный голос;
2. трахеопищеводное шунтирование с голосовым протезом;
3. электронные голосообразующие аппараты (электрогортань).

Активную тренировку не проводят в раннем послеоперационном периоде, на этапе заживления и при свищах.

Всем пациентам до начала лечения показаны профилактическая гимнастика и занятия при дисфагии для уменьшения нарушений глотания.

Нутритивная поддержка **не менее 7 суток** показана всем пациентам.

Показания к нутритивной поддержке перед операцией (достаточно одного признака)

1. потеря 10% массы тела и более за 6 месяцев;
2. индекс массы тела (ИМТ) менее 20 кг/м^2;
3. белок менее 60 г/л или альбумин менее 30 г/л;
4. ухудшение возможности приёма пищи за последнюю неделю.

Показания к нутритивной поддержке при химиотерапии

1. ИМТ менее 20 кг/м^2;
2. потеря более 5% массы тела за 6 месяцев;
3. белок менее 60 г/л или альбумин менее 30 г/л;
4. невозможность адекватного питания через рот;
5. энтеропатия средней и тяжёлой степени.

При невозможности адекватного питания через рот устанавливают назогастральный зонд (на срок **до 3–4 недель**) или выполняют гастростомию.

Всем пациентам перед ЛТ или ХЛТ показаны консультация и сопровождение стоматолога. Удаление зубов в облучённой зоне выполняется только при необходимости и на фоне антибиотикотерапии (риск лучевого остеомиелита).

Для профилактики и лечения мукозита на фоне ХЛТ применяется низкоинтенсивная лазеротерапия; при болевом синдроме показана консультация альголога.

Облучённые ткани очень ранимы: в ранние сроки после лучевой терапии следует избегать инвазивных диагностических процедур и биопсии без крайней необходимости.

Ведение лучевого мукозита

1. с момента проявлений и до полного исчезновения мукозита применяют ранозаживляющие местные средства (гели, раствор мочевины и др.);
2. полость рта регулярно орошают изотоническим раствором;
3. для аппликаций в полости рта или закапывания в нос используют масла (оливковое, персиковое, облепихи или шиповника);
4. при болевом синдроме применяют местные и системные обезболивающие средства по шкале ВОЗ, как правило опиаты, в том числе трансдермальные формы.

На фоне лекарственной и химиолучевой терапии показана лечебная физкультура (аэробные упражнения и упражнения на сопротивление, тренировка баланса при полинейропатии).

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Частота наблюдения после лечения

1. 1-й год: **каждые 1–3 месяца**;
2. 2-й год: **каждые 2–6 месяцев**;
3. 3–5 лет: **1 раз в 4–8 месяцев**;
4. после 5 лет: 1 раз в год или при жалобах.

Объём обследования

1. анамнез и осмотр, фиброларингоскопия;
2. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон, органов брюшной полости и малого таза;
3. рентгенография грудной клетки каждые 12 месяцев, КТ и МРТ по показаниям;
4. ПЭТ-КТ после индукционной ХТ: **не ранее чем через 2–3 месяца**;
5. ТТГ каждые 6–12 месяцев (функция щитовидной железы).

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой специалист направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи; консультация проводится **не позднее 5 рабочих дней**, патологоанатомическое исследование выполняется в срок **не более 15 рабочих дней**. Тактику лечения определяет онкологический консилиум.

5.3 Показания к госпитализации

1. **экстренная госпитализация**: осложнения заболевания или лечения, требующие специализированной помощи;
2. **плановая госпитализация**: сложные интервенционные диагностические вмешательства, специализированное противоопухолевое лечение.

5.4 Критерии выписки

1. завершение курса лечения или одного из его этапов при отсутствии осложнений, требующих медикаментозной коррекции или медицинских вмешательств в стационарных условиях;
2. отказ пациента или его законного представителя от лечения, установленного консилиумом, при отсутствии таких осложнений;
3. несоблюдение пациентом предписаний или правил внутреннего распорядка, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих;
4. необходимость перевода в другую медицинскую организацию по профилю; решение о переводе принимается после консультации врачей-специалистов принимающей организации.

Факторы прогноза

1. размер и распространённость первичной опухоли;
2. степень дифференцировки;
3. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
4. метастазы в лимфоузлах шеи (вдвое снижают выживаемость), экстранодальное распространение;
5. индекс Ki-67, статус краёв резекции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак гортани»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 14.08.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года (по тексту КР)
Код в рубрикаторе	475_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 «Группировка по стадиям» в стадии IVA указано «T4 N0, N1, N2», тогда как T4b относится к стадии IVB; в IVA должна входить только T4a.

Клинические рекомендации

Рак гортаноглотки

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C12** — Злокачественное новообразование грушевидного синуса **C13** — Злокачественное новообразование нижней части глотки
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 13.08.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/27_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 27.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рак гортаноглотки — злокачественная опухоль из элементов неороговевающего эпителия гортаноглотки. На ранних стадиях протекает бессимптомно; основными жалобами являются боль при глотании с иррадиацией в ухо на стороне поражения и осиплость.
- Заподозрить рак позволяют боль в горле и при глотании, не проходящая на фоне антибактериального и противовоспалительного лечения, стойкая осиплость, постоянный кашель и увеличение шейных лимфоузлов.
- К предопухолевым заболеваниям относятся хронические ларингиты, лейкоплакия слизистой оболочки гортаноглотки, папилломы и рецидивирующий папилломатоз, пахидермия, дискератоз.
- Всем пациентам с подозрением на рак гортаноглотки показана фиброларингоскопия с биопсией слизистой оболочки и патологоанатомическим исследованием; увеличенные лимфоузлы шеи пунктируют для цитологического исследования.
- При подозрении на онкологическое заболевание пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи (первичный онкологический кабинет); консультация должна состояться **не позднее 5 рабочих дней** с даты направления.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Голосообразующий аппарат (электрогортань) — вибрирующий электронный аппарат, который прикладывают к подбородку: он преобразует колебания мышц дна полости рта в голос. Голос при этом металлический, лишённый тембровой и эмоциональной окраски.

1. **прогрессирование** — новый опухолевый очаг и (или) рост первичного или метастатического очага более чем на 25%
2. **стабилизация** — уменьшение очага менее чем на 50% или увеличение менее чем на 25% без новых очагов

2.2 Этиология и эпидемиология

К факторам риска относятся длительное курение, алкоголь, работа в условиях запылённости (текстильное производство), вдыхание канцерогенов (нефть и продукты её перегонки, бензол, фенольные смолы, асбест). Высокий риск озлокачествления отмечается при папилломах (рак, ассоциированный с ВПЧ), рецидивирующем папилломатозе, пахидермии, дискератозе, хронических ларингитах.

Заболеваемость раком гортаноглотки в России в 2020 г. составила 0,39–0,98 на 100 тыс. мужчин и 0,12–0,18 на 100 тыс. женщин. В мире в 2020 г. впервые выявлено 84 254 случая, в том числе 70 254 у мужчин.

2.3 Клиническая картина

На ранних стадиях течение бессимптомное. Первыми жалобами, как правило, становятся:

1. дисфагия: локальная болезненность при глотании, иногда с иррадиацией в ухо на стороне поражения; поперхивание пищей, ощущение «перекатывания» слюны через «валик», задержка пищи;
2. нарушение голоса (осиплость), реже кашель;
3. затруднение дыхания при перекрытии просвета гортани.

При распаде опухоли присоединяются гнилостный запах изо рта и кровохарканье.

2.4 Классификация TNM (8-е издание AJCC)

Символ T: первичная опухоль гортаноглотки

T	Первичная опухоль (клиническая)
T1	ограничена одним отделом гортаноглотки и (или) не более 2 см
T2	более одного отдела или прилежащие зоны, либо более 2 см, но не более 4 см, без ограничения подвижности голосовой связки на стороне поражения
T3	более 4 см, либо с ограничением подвижности голосовой связки, либо распространяется на пищевод
T4a / T4b	T4a — щитовидный или перстневидный хрящ, подъязычная кость, щитовидная железа, мышцы пищевода, мягкие ткани центрального треугольника шеи; T4b — предпозвоночная фасция, окутывание сонной артерии, средостение

1. **N1** — один лимфоузел на стороне поражения до 3 см, без экстракапсулярной инвазии (ENE−)
2. **N2** — один узел на стороне поражения 3–6 см ENE−; или несколько ипсилатеральных до 6 см ENE−; или с обеих сторон либо контралатеральные до 6 см ENE−
3. **N3** — узел более 6 см ENE−; или любой метастаз с ENE+

Группировка по стадиям (клиническая TNM):

1. 0 — Tis N0 M0;
2. I — T1 N0 M0;
3. II — T2 N0 M0;
4. III — T3 N0 M0 либо T1–3 N1 M0;
5. IVA — T4a N0–2 M0 либо T1–3 N2 M0;
6. IVB — любая T N3 M0 либо T4b любая N M0;
7. IVC — любая T, любая N, M1.

Степень дифференцировки: G1 — высоко-, G2 — умеренно-, G3 — низкодифференцированный рак.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: новообразование, не поддающееся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**;
2. физикального обследования: осмотр, пальпация образования, прилежащих тканей и регионарных лимфоузлов;
3. цитологического исследования пунктата опухоли и лимфоузлов;
4. биопсии слизистой оболочки гортаноглотки с патологоанатомическим исследованием;
5. инструментального обследования: УЗИ шеи, фиброларингоскопия, КТ или МРТ, ПЭТ-КТ по показаниям.

3.2 Жалобы и анамнез

Тщательный сбор жалоб и анамнеза необходим для выбора тактики лечения. Кроме того, пациента консультируют по отказу от курения и сохранению репродуктивной функции, проводят скрининг депрессии.

3.3 Осмотр и пальпация

Всем пациентам необходимы тщательный осмотр и бимануальная пальпация очага и регионарных лимфоузлов для оценки распространённости опухоли, нутритивного статуса, нарушений речи и глотания.

На что обращают внимание

1. изменение контуров шеи, увеличение регионарных лимфоузлов;
2. подвижность и изменения остова гортани;
3. опухоль при непрямой ларингоскопии.

3.4 Фиброларингоскопия

Фиброларингоскопия выполняется всем пациентам для оценки распространённости процесса.

3.5 Пункция лимфоузлов шеи под контролем УЗИ

Увеличенные лимфоузлы шеи (II–V уровни) пунктируют под контролем УЗИ для уточнения распространённости и планирования лечения.

3.6 КТ и МРТ головы и шеи

КТ с контрастированием или МРТ головы и шеи выполняют при подозрении на распространение опухоли на хрящи гортани, основание черепа, магистральные сосуды шеи.

3.7 Рентгенография и КТ органов грудной клетки

Рентгенографию или КТ органов грудной клетки выполняют при распространённом раке с поражением шейных лимфоузлов для выявления отдалённых метастазов.

3.8 ПЭТ-КТ

ПЭТ-КТ выполняют через 2–3 месяца после лучевой или химиолучевой терапии, когда решается вопрос об отказе от лимфаденэктомии, а также по индивидуальным показаниям.

3.9 Лабораторные и морфологические исследования

Специфических лабораторных исследований нет; их объём определяет врач-онколог.

Основным методом верификации опухоли гортаноглотки является морфологическое исследование биопсийного материала.

В заключении по операционному материалу отражают

1. размеры и глубину инвазии опухоли;
2. гистологическое строение и степень дифференцировки;
3. лимфоваскулярную и периневральную инвазию;
4. pT и pN (число исследованных и поражённых лимфоузлов, экстранодальное распространение);
5. состояние краёв резекции, прорастание хрящей гортани и окружающих тканей.

---

4. Лечение

4.1 Тактика лечения по стадиям

Тактика зависит от локализации и распространённости опухоли, её чувствительности к лучевому и лекарственному лечению и направлена на излечение с восстановлением глотания, голоса, дыхания и защитной функции.

Лечение рака гортаноглотки по стадиям

Стадия	Рекомендованное лечение
T1–2 N0	радикальная ЛТ (при T2N0 — одновременная ХЛТ) либо органосохраняющее хирургическое лечение: трансоральная лазерная резекция или частичная ларингофарингэктомия с шейной лимфодиссекцией по показаниям
T1 N+, T2–3 любая N (резектабельная)	индукционная ХТ с последующей одновременной ХЛТ; либо парциальная или тотальная ларингофарингэктомия с одно- или двусторонней шейной диссекцией
T4a любая N	ларингофарингэктомия с шейной лимфодиссекцией (включая VI уровень) + геми- или тиреоидэктомия с последующей ЛТ или ХЛТ; либо индукционная ХТ; либо одновременная ХЛТ

После операции тактику определяют по неблагоприятным прогностическим факторам (НПФ) в операционном материале.

Неблагоприятные прогностические факторы

1. экстранодальное распространение (ENE+);
2. положительные края резекции или рост опухоли вблизи края;
3. pT3–4, pN2–3;
4. перineвральная, сосудистая, лимфатическая инвазия.

Тактика после операции

1. **нет НПФ и pN0** — дополнительное лечение не требуется, динамическое наблюдение
2. **один pN1 без ENE или один НПФ** — послеоперационная ЛТ
3. **два НПФ и более** — послеоперационная ХЛТ
4. **R1 (микроскопическая остаточная опухоль)** — перерезекция, при невозможности — одновременная ХЛТ
5. **ENE+** — конкурентная ХЛТ

Тактика после индукционной химиотерапии

1. **полная регрессия очага после индукционной ХТ** — самостоятельная ЛТ или ХЛТ
2. **частичная регрессия** — ХЛТ или хирургическое лечение
3. **регрессия менее 50%** — хирургическое лечение, затем решение о ЛТ/ХЛТ
4. **остаточная опухоль и (или) метастатические узлы после ЛТ/ХЛТ** — хирургическое лечение

Эффект консервативной терапии оценивают через 2–3 месяца после завершения курса.

Локальный рецидив или остаточная опухоль без предшествующей лучевой терапии:

1. **хирургическое вмешательство** — при резектабельном процессе
2. **одновременная ХЛТ** — также рекомендована, без условия резектабельности
3. **индукционная ХТ с последующей одновременной ХЛТ** — при ECOG 0–1
4. **паллиативная ЛТ или лекарственная терапия одним препаратом** — при нерезектабельном процессе и ECOG 2

Локальный рецидив или остаточная опухоль после лучевой терапии:

1. **резектабельный процесс** — хирургическое вмешательство с обсуждением повторной ЛТ или ХЛТ
2. **нерезектабельный** — лекарственная терапия, повторная ЛТ/ХЛТ или симптоматическое лечение
3. **отдалённые метастазы, ECOG 0–1** — лекарственная терапия
4. **отдалённые метастазы, ECOG 2** — лекарственная терапия или симптоматическое лечение
5. **ECOG 3** — симптоматическое лечение

4.2 Хирургическое лечение

Операции направлены на удаление первичного очага и восстановление верхних отделов ЖКТ.

Объёмы вмешательства

1. органосохраняющие: эндоларингеальная лазерная или эндоскопическая резекция;
2. открытые резекции отделов гортаноглотки, комбинированная горизонтальная резекция гортани;
3. ларингэктомия с реконструкцией (перемещённым лоскутом, микрососудистой), возможно голосовое протезирование.

При отсутствии клинических признаков поражения лимфоузлов всем пациентам рекомендуется профилактическая одно- или двусторонняя шейная лимфодиссекция (2–4 уровни): риск регионарного метастазирования высок даже при T1–2 (50% случаев).

Удаление лимфоузлов II–V уровней — при одном из факторов

1. пальпируемый метастаз в IV или V уровне;
2. регионарный метастаз более 6 см;
3. крупные множественные метастазы (более 3 см);
4. выраженное экстракапсулярное распространение (грудино-ключично-сосцевидная мышца, внутренняя яремная вена, общая сонная артерия);
5. регионарный рецидив.

Лимфоузлы VI уровня удаляют при T3–4a или подозрении на метастазы в этом уровне.

4.3 Лучевая и лекарственная терапия

Доза самостоятельной ЛТ на первичный очаг и клинически определяемые регионарные метастазы составляет 66–70 Гр (2,0–2,2 Гр за фракцию) **за 6–7 недель**; на зоны субклинического поражения подводят 44–63 Гр.

Предпочтительные методы облучения

1. конформная дистанционная ЛТ (3D-CRT);
2. ЛТ с модуляцией интенсивности (IMRT);
3. объёмно-модулированная ЛТ (VMAT);
4. протонная ЛТ — альтернатива для снижения частоты и выраженности лучевых реакций.

При одновременной ХЛТ подводят 70 Гр за 7 недель; стандартом является цисплатин 100 мг/м^2 в 1, 22 и 43-й дни ЛТ. После индукционной ПХТ альтернативой цисплатину служат карбоплатин (AUC 1,5–2 еженедельно) или цетуксимаб.

Цетуксимаб вместо препаратов платины — при высоком риске их побочных эффектов

1. СКФ **менее 50–60 мл/мин**;
2. возраст **старше 65 лет**;
3. выраженная сопутствующая почечная, сердечно-сосудистая, неврологическая, печёночная патология;
4. ослабленное состояние (ECOG более 1).

Послеоперационная ЛТ рекомендована при pT3 N0, а также у отдельных пациентов с pT1–2 N1 и неблагоприятными признаками. ЛТ начинают **не позднее 6 недель** после операции. Доза на ложе опухоли составляет 60–66 Гр за 6–6,5 недель, на зоны регионарного метастазирования — 44–63 Гр.

Лекарственная терапия индивидуализируется с учётом общего состояния пациента и целей лечения; приведённые схемы предназначены для плоскоклеточного рака.

Индукционная полихимиотерапия (режим TPF):

1. доцетаксел: 75 мг/м² внутривенно в 1-й день;
2. цисплатин: 75 мг/м² внутривенно в 1-й день;
3. фторурацил: 1000 мг/м²/сут внутривенно в 1–4-й дни;
4. курс: всего 2–3 курса с интервалом 3 недели.

Конкурентная ХТ после индукции: цисплатин 100 мг/м² 1 раз в 3 недели; при высокой токсичности возможно еженедельное введение карбоплатина (AUC 1,5–2) или цетуксимаба. При сопутствующей патологии, препятствующей платиносодержащим схемам (почечная недостаточность, кардиопатология), препараты платины заменяют цетуксимабом.

При неоперабельном рецидиве, остаточной опухоли после ЛТ и при отдалённых метастазах рекомендуется моно- или полихимиотерапия; режимы приведены в таблице ниже.

Режимы лекарственной терапии плоскоклеточного рака головы и шеи

Режим	Схема проведения
PF + цетуксимаб	цисплатин 75–100 мг/м² в/в в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м²/сут в/в 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза), далее 250 мг/м² в/в еженедельно; после 6 циклов при отсутствии прогрессирования — поддерживающая терапия цетуксимабом 250 мг/м² еженедельно
DC + цетуксимаб	#доцетаксел 75 мг/м² + цисплатин 75 мг/м² в/в в 1-й день каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза), далее #цетуксимаб 250 мг/м² еженедельно; после 4 циклов — поддерживающая терапия цетуксимабом 500 мг/м² 1 раз в 2 недели
Цисплатин + цетуксимаб	цисплатин 75–100 мг/м² 1 раз в 3 недели (не более 6–8 введений) + цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день, далее 250 мг/м² еженедельно до прогрессирования или непереносимой токсичности
Паклитаксел + карбоплатин + цетуксимаб	1. #паклитаксел 100 мг/м² + карбоплатин AUC 2,5 в 1-й и 8-й дни + цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день 1-го цикла, далее 250 мг/м² еженедельно; цикл 21 день; 2. #паклитаксел 175 мг/м² + карбоплатин AUC 5–6 в 1-й день + цетуксимаб 400 мг/м², далее #цетуксимаб 250 мг/м² еженедельно; цикл 21 день; после 6 циклов — поддерживающая терапия #цетуксимабом 250 мг/м² еженедельно; 3. при ECOG 2: #паклитаксел 80 мг/м² + карбоплатин AUC 2,0 еженедельно + цетуксимаб 400 мг/м², далее 250 мг/м² еженедельно, затем поддерживающая терапия #цетуксимабом 250 мг/м².
PF	1. цисплатин 75–100 мг/м² в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели; 2. карбоплатин AUC 5 в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни каждые 3 недели; 3. 6 циклов, при отсутствии токсичности и нарастающем эффекте — до 8.
Паклитаксел + карбоплатин	1. #паклитаксел 175 мг/м² + карбоплатин AUC 5–6 в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов (до 8); 2. #паклитаксел 60–80 мг/м² + карбоплатин AUC 2 еженедельно до прогрессирования или неприемлемой токсичности, не более 18 недель.
DC	#доцетаксел 75 мг/м² + цисплатин 75 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов (до 8)
Ниволумаб	3 мг/кг 1 раз в 2 недели, или 240 мг 1 раз в 2 недели, или 480 мг 1 раз в 4 недели до прогрессирования или неприемлемой токсичности, не более 2 лет

Режим	Схема проведения
Пембролизумаб	#пембролизумаб 200 мг 1 раз в 3 недели или 400 мг 1 раз в 6 недель до прогрессирования или неприемлемой токсичности, не более 2 лет
PF + пембролизумаб	#пембролизумаб 200 мг + карбоплатин AUC 5 или цисплатин 100 мг/м² + #фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни 1 раз в 3 недели (6 циклов), далее пембролизумаб 200 мг 1 раз в 3 недели или 400 мг 1 раз в 6 недель, всего до 35 введений
Монотерапия при ECOG более 2 (по таблице КР)	1. цисплатин 60–70 мг/м² 1 раз в 3 недели (длительность более 6–8 введений сомнительна); 2. карбоплатин AUC 5–6 1 раз в 3 недели или AUC 2 еженедельно; 3. #паклитаксел 175 мг/м² 1 раз в 3 недели или 80 мг/м² еженедельно; 4. #доцетаксел 70–75 мг/м² 1 раз в 3 недели; 5. #капецитабин 2000 мг/м² внутрь в 2 приёма в 1–14-й дни, перерыв 1 неделя, или 2000 мг/сут ежедневно в метрономном режиме; 6. #метотрексат 40 мг/м² еженедельно; 7. #цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день, далее 250 мг/м² еженедельно.

Примечания к таблице

1. PF, паклитаксел + карбоплатин и DC — неоптимальные режимы: только при абсолютных противопоказаниях к анти-EGFR моноклональным антителам;
2. ниволумаб — во 2-й и последующих линиях при платинорезистентных опухолях, независимо от экспрессии PD-L1;
3. пембролизумаб — в 1-й линии при PD-L1 CPS более 20; при прогрессировании на фоне или после платиносодержащей ХТ — при TPS ≥ 50%;
4. PF + пембролизумаб — в 1-й линии при экспрессии PD-L1 ≥ 1%.

4.4 Медицинская реабилитация

Всем пациентам до начала лечения рекомендуются программы профилактической гимнастики и обучение тактике глотания: они уменьшают нарушения глотания при противоопухолевой терапии.

Нутритивная поддержка при планировании хирургического лечения необходима при одном из факторов:

1. потеря 10% и более массы тела за 6 месяцев;
2. индекс массы тела менее 20 кг/м²;
3. белок менее 60 г/л или альбумин менее 30 г/л;
4. ухудшение приёма пищи за последнюю неделю.

На фоне химио- и химиолучевой терапии рекомендуется лечебная физкультура (аэробные упражнения и упражнения на сопротивление) для профилактики саркопении, уменьшения слабости и утомляемости.

Низкоинтенсивную лазеротерапию применяют для профилактики и лечения мукозита полости рта на фоне химиотерапии и лучевого дерматита. При лучевом мукозите используют ранозаживляющие средства, орошение изотоническим раствором, местные анестетики и системные анальгетики (чаще опиоиды, в том числе трансдермальные).

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика и ранняя диагностика

На что обращают внимание

1. первичные симптомы: парестезия, сухость, чувство инородного тела в горле, боль при глотании с иррадиацией в ухо, позже гнилостный запах, кровохарканье, образования на шее;
2. канцерогенные факторы: курение (в том числе пассивное), алкоголь, асбест, древесная пыль, продукты нефтепереработки, ионизирующее облучение;
3. предопухолевые заболевания: хронические воспалительные заболевания, лейкоплакия слизистой оболочки гортаноглотки, папилломы.

5.2 Диспансерное наблюдение

Частота наблюдения у онколога после лечения

1. 1-й год — **каждые 1–3 месяца**;
2. 2-й год — **каждые 2–6 месяцев**;
3. 3–5 лет — **1 раз в 4–8 месяцев**;
4. после 5 лет — 1 раз в год или при жалобах.

Объём обследования

1. анамнез, физикальное обследование, фиброларингоскопия;
2. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон, органов брюшной полости и малого таза;
3. КТ или МРТ головы и шеи — по показаниям и при недоступности зоны осмотру;
4. рентгенография или КТ органов грудной клетки каждые 12 месяцев;
5. ПЭТ-КТ — по показаниям;
6. ТТГ каждые 6–12 месяцев, если проводилось облучение шеи.

5.3 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой специалист направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи (первичный онкологический кабинет) для первичной специализированной помощи. Тактику лечения определяет консилиум врачей-онкологов и радиотерапевтов.

1. **экстренная или неотложная госпитализация** — осложнения заболевания или лечения, требующие специализированной помощи
2. **плановая** — сложные интервенционные диагностические вмешательства; специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в стационаре

Факторы прогноза

1. размеры и распространённость первичной опухоли;
2. степень дифференцировки;
3. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
4. статус регионарных лимфоузлов (pN): метастазы в лимфоузлах шеи вдвое снижают выживаемость;
5. экстранодальное распространение; статус краёв резекции (R0–1).

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак гортаноглотки»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 13.08.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года (по общему правилу пересмотра)
Код в рубрикаторе	27_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 монотерапия предназначена «для пациентов в общем состоянии по ECOG> 2 баллов», тогда как в разделе 3.1 лекарственная терапия одним препаратом рекомендована при ECOG 2, а при ECOG 3 — только симптоматическое лечение. Вероятно, имеется в виду ECOG 2 (так же сформулирована сноска 1 к таблице).

Клинические рекомендации

Рак носоглотки

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C11** — Злокачественное новообразование носоглотки
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.08.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/535_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рак носоглотки — злокачественная опухоль, развивающаяся из неороговевающего эпителия носоглотки.
- Начальные проявления в большинстве случаев скрываются под маской ОРВИ, ринофарингита, аденоидных вегетаций; нередко первым признаком становятся увеличенные лимфоузлы шеи.
- Поводом заподозрить опухоль являются затруднение носового дыхания, гнусавость, заложенность или пощёлкивание в ухе, снижение слуха, образование на шее.
- Диагноз подтверждает эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа и носоглотки с биопсией; распространённость оценивают по МРТ (предпочтительно) или КТ лицевого отдела черепа и шеи.
- Основным методом радикального лечения является лучевая или химиолучевая терапия.
- При подозрении на рак носоглотки пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи или первичный онкологический кабинет; тактику лечения определяет онкологический консилиум.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Стенки носоглотки

1. **верхняя** — основная кость, часть затылочной кости;
2. **задняя** — I и II шейные позвонки;
3. **передняя** — хоаны;
4. **боковые** — глоточные отверстия слуховых труб;
5. **нижняя** — твёрдое нёбо.

Оценка эффекта лечения

1. **полный эффект** — отсутствие признаков опухоли по данным лабораторных и инструментальных методов;
2. **частичная регрессия** — сокращение опухолевых очагов более чем на 50% при отсутствии новых;
3. **прогрессирование** — новый очаг и (или) рост первичного или метастатических очагов более чем на 25%.

2.2 Этиология

Этиологические факторы

1. инфицирование вирусом Эпштейна — Барр (ВЭБ);
2. хронические воспалительные процессы, вызывающие гиперплазию и метаплазию слизистой оболочки носоглотки;
3. анатомические особенности некоторых рас: более высокая заболеваемость у народов Юго-Восточной Азии, Африки, Индокитая.

Канцерогенные факторы

1. курение, в том числе пассивное;
2. контакт с асбестом, древесной пылью, продуктами нефтепереработки;
3. ионизирующее излучение;
4. вирус Эпштейна — Барр.

Заболеваемость раком носоглотки в России в 2023 г. составила 0,36 на 100 тыс. населения; у мужчин — 0,53, у женщин — 0,2 на 100 тыс.

2.3 Клиническая картина

Клиническая картина складывается из местных симптомов, признаков регионарного и отдалённого метастазирования, общего опухолевого симптомокомплекса. Начальные проявления в большинстве случаев маскируются под ОРВИ, ринофарингит, аденоидные вегетации; нередко к врачу заставляют обратиться увеличенные лимфоузлы шеи.

На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно; симптомы зависят от локализации опухоли и направления её роста.

Первичные симптомы

1. прогрессирующее затруднение носового дыхания, гнусавость;
2. пощёлкивание или заложенность уха, снижение слуха, боль в ухе;
3. головная боль, кровотечения;
4. экзофтальм, птоз, косоглазие;
5. тризм жевательной мускулатуры, расстройство глотания и фонации;
6. провисание мягкого нёба, неподвижность половины гортани, отклонение языка в сторону;
7. образования на шее.

2.4 Гистологические варианты

Среди злокачественных опухолей носоглотки преобладают эпителиальные; рак составляет около 70%.

Гистологические варианты рака носоглотки

1. плоскоклеточный ороговевающий рак;
2. плоскоклеточный неороговевающий рак (дифференцированный и недифференцированный);
3. базалоидный вариант плоскоклеточного рака.

2.5 Классификация TNM (8-е издание)

Символ T

T	Первичная опухоль
T0	первичная опухоль не определяется, но имеется поражение регионарных лимфоузлов, связанное с ВЭБ
Tis	преинвазивная карцинома
T1	в пределах носоглотки или с распространением в ротоглотку или полость носа без распространения в парафарингеальное пространство
T2	распространение в парафарингеальное пространство
T3	распространение на основание черепа и (или) придаточные пазухи носа
T4	интракраниальное распространение и (или) поражение черепных нервов, распространение в орбиту, подвисочную ямку, жевательное пространство

1. **N1** — метастазы в шейных лимфоузлах выше надключичной ямки на стороне поражения не более 6 см и (или) одно- или двусторонние ретрофарингеальные не более 6 см;
2. **N2** — двусторонние метастазы в шейных лимфоузлах выше надключичной ямки до 6 см;
3. **N3** — метастазы более 6 см и (или) ниже нижнего края перстневидного хряща.

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
0 / I / II / III	TisN0 / T1N0 / T0–T1N1, T2N0–N1 / T0–T2N2, T3N0–N2
IVA / IVB / IVC	T4N0–N2 / любая T N3 / M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнестических данных;
2. клинической картины и осмотра с пальпацией регионарных лимфоузлов;
3. цитологического исследования отделяемого верхних дыхательных путей, отпечатков, пунктата увеличенных лимфоузлов;
4. патологоанатомического исследования биопсийного материала;
5. инструментального обследования: фиброларингоскопия, КТ или МРТ, ПЭТ-КТ по показаниям;
6. определения ДНК вируса Эпштейна — Барр.

3.2 Жалобы и анамнез

При подозрении на рак носоглотки необходим тщательный сбор жалоб и анамнеза; стаж курения оценивают в пачка-летах.

Факторы риска

1. курение, употребление крепких спиртных напитков;
2. производственные вредности;
3. хроническая инфекция: хронический фарингит, отит, ринит, вирус Эпштейна — Барр.

3.3 Риноскопия и пальпация лимфатических узлов

Физикальное обследование при подозрении на рак носоглотки включает

1. переднюю и заднюю риноскопию;
2. пальпацию регионарных лимфоузлов;
3. оценку нутритивного статуса.

3.4 ДНК вируса Эпштейна — Барр в крови

Количественное определение ДНК ВЭБ методом ПЦР в периферической крови выполняют при раке носоглотки или подозрении на него для верификации опухоли и оценки эффекта лечения.

ДНК ВЭБ методом ПЦР в реальном времени выявлена у 96% пациентов с раком носоглотки и у 7% здоровых. Высокий исходный или сохраняющийся к концу ЛТ уровень ДНК ВЭБ связан с неблагоприятным прогнозом.

3.5 Эндоскопическая эндоназальная ревизия носоглотки

Диагноз подтверждается эндоскопической эндоназальной ревизией полости носа и носоглотки с биопсией, мазками-отпечатками с поверхности эрозий и изъязвлений, пункцией уплотнений без изъязвления.

3.6 УЗИ лимфатических узлов шеи

УЗИ лимфоузлов шеи с обеих сторон выполняют каждому пациенту, подозрительные узлы пунктируют для цитологического и патологоанатомического исследования.

При подозрении на метастазы в лимфоузлах шеи показано цитологическое исследование материала тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем УЗИ.

3.7 МРТ и КТ лицевого отдела черепа и шеи

Распространённость опухоли оценивают по КТ лицевого отдела черепа с болюсным контрастированием и (или) МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием. Предпочтительна МРТ; КТ дополняет её при опухоли у основания черепа для оценки костной деструкции.

Зона исследования шеи: от основания черепа до верхней апертуры грудной клетки, при поражении лимфоузлов ниже перстневидного хряща — до бифуркации трахеи. При большом интракраниальном компоненте дополнительно выполняют МРТ головного мозга.

Для планирования ЛТ выполняют МРТ лицевого отдела черепа с контрастированием, для оценки распространения на кости основания черепа КТ с болюсным контрастированием. При невозможности МРТ выполняют КТ или ПЭТ-КТ.

3.8 КТ органов грудной полости и ПЭТ-КТ

Стадирование

1. КТ органов грудной полости, при невозможности прицельная рентгенография органов грудной клетки;
2. ПЭТ-КТ с ФДГ при местно-распространённом процессе и метастазах в регионарных лимфоузлах для поиска отдалённых метастазов.

3.9 Оценка эффективности лечения

Через **2–3 месяца** после ЛТ или ХЛТ всем пациентам выполняют МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием; при неоднозначном результате показана ПЭТ-КТ для отличия постлучевых изменений от рецидива.

При регионарных метастазах ПЭТ-КТ с ФДГ выполняют **не ранее чем через 3 месяца** после ЛТ или ХЛТ для решения вопроса о шейной лимфодиссекции.

Через **2–3 месяца** после ЛТ или ХЛТ подозрительные лимфоузлы шеи пунктируют под контролем УЗИ, чтобы подтвердить полную резорбцию метастазов и решить вопрос об отказе от лимфаденэктомии.

Подозрительными считают лимфоузлы шеи I–IV групп **более 2 см**, V группы **более 1 см**, а также узлы с изменённой структурой по данным УЗИ.

---

4. Лечение

Основным методом радикального лечения является лучевая или химиолучевая терапия.

4.1 Лечение по стадиям

Стадия	Тактика лечения
T1N0M0	самостоятельная ЛТ
T2N0M0	самостоятельная ХЛТ
T1N1–3, T2–T4 любая N	одновременная ХЛТ, затем адъювантная ХТ (2 цикла), или индукционная ХТ (3 цикла), затем одновременная ХЛТ

Стадия	Тактика лечения
любая T и N, M1	ХТ с препаратами платины, предпочтительно в сочетании с камрелизумабом в 1-й линии независимо от экспрессии PD-L1 и статуса ВЭБ

При остаточных метастатических лимфоузлах после консервативного лечения целесообразно хирургическое лечение; при полной регрессии узлов — динамическое наблюдение.

После ХЛТ при местно-распространённом раке III–IVA стадии (кроме T3–4N0 и T3N1) может быть рассмотрена адъювантная ХТ #капецитабином 650 мг/м² 2 раза в сутки в течение 1 года, начатая не позднее 12–16 недель после ХЛТ.

Изучен и другой режим адъювантного #капецитабина после ХЛТ: 1,0 г/м² в 1–14-й дни, затем неделя перерыва, 8 курсов (кратность приёма в тексте КР пропущена).

Индукция по схеме DCF (доцетаксел, цисплатин, фторурацил) с последующей ХЛТ при T3–4N+ улучшает 3-летнюю безрецидивную и общую выживаемость по сравнению с одновременной ХЛТ.

4.2 Рецидив или остаточная опухоль после лучевой терапии

В 1-й линии применяют ХТ с препаратами платины, предпочтительно в сочетании с камрелизумабом. При резектабельной опухоли обсуждают операцию и повторную ЛТ или ХЛТ, при нерезектабельной — повторную ЛТ или ХЛТ, лекарственную терапию либо симптоматическое лечение.

Повторная ЛТ обсуждается при общем состоянии ECOG 0–1 и **не ранее 6 месяцев** (предпочтительно **не ранее 2 лет**) после предшествующего облучения.

Рецидив или остаточная опухоль с отдалёнными метастазами

1. **ECOG 0–1**: лекарственное лечение (полихимиотерапия, монохимиотерапия или иммунотерапия) с учётом первичного лечения;
2. **ECOG 2**: монохимиотерапия или симптоматическое лечение;
3. **ECOG 3**: симптоматическое лечение.

4.3 Лучевая терапия

При самостоятельной ЛТ на первичный очаг подводят 66–70 Гр (1,8–2,2 Гр за фракцию), на локорегионарную область с лимфоузлами — 50 Гр (2,0 Гр за фракцию) или 54–63 Гр (1,6–1,8 Гр за фракцию).

При одновременной ХЛТ на первичный очаг и регионарные метастазы подводят 70 Гр (2,0 Гр за фракцию) ежедневно с понедельника по пятницу **в течение 7 недель**, на локорегионарную область — 50 Гр или 54–63 Гр.

Паллиативную ЛТ применяют для облегчения или профилактики локорегионарных симптомов при невозможности радикального лечения, в том числе 50 Гр (2,5 Гр за фракцию) или 30 Гр (3 Гр за фракцию).

ЛТ проводят в специализированных учреждениях с опытом лечения рака носоглотки. Предпочтительны высокопрецизионные методы (IMRT, VMAT), при значительных ограничениях дозы на нормальные ткани — протонная терапия; допустима 3D-конформная ЛТ.

До лечения пациента оценивает радиотерапевт. Объём облучения до радикальных доз не изменяют по ответу на индукционную ПХТ, кроме случаев прогрессии; при быстрых анатомических изменениях (уменьшение опухоли, потеря массы тела) возможно повторное планирование.

4.4 Лекарственное лечение

При одновременной ХЛТ применяют цисплатин 100 мг/м² на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни ЛТ (суммарно 300 мг/м²). После индукционной ПХТ альтернативой цисплатину является карбоплатин AUC 1,5–2,0 еженедельно с первого дня ЛТ.

Схемы индукционной ХТ

1. доцетаксел 75 мг/м² и цисплатин 75 мг/м² в 1-й день, фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни; 3 цикла с интервалом 3 недели;
2. #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни и цисплатин 80 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели; 3 цикла;
3. #гемцитабин 1000 мг/м² и цисплатин 40 мг/м² в 1-й и 8-й дни каждые 3 недели; 3 цикла.

При ХЛТ с последующей адъювантной ХТ цисплатин вводят в дозе 100 мг/м² 1 раз в 3 недели или 40 мг/м² еженедельно на фоне ЛТ.

Схемы адъювантной ХТ

1. цисплатин 80 мг/м² в 1-й день и фторурацил 1000 мг/м²/сут в 1–4-й дни каждые 4 недели, 3 цикла; при невозможности введения цисплатина — карбоплатин;
2. #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни и цисплатин 80 мг/м² в 1-й день каждые 4 недели, 3 цикла;
3. #гемцитабин 1000 мг/м² и цисплатин 30 мг/м² в 1-й и 8-й дни каждые 3 недели, 3 цикла;
4. #капецитабин 650 мг/м² внутрь 2 раза в сутки в течение года.

При рецидиве и отдалённых метастазах в 1-й линии применяют камрелизумаб 200 мг в 1-й день, #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни, цисплатин 80 мг/м² в 1-й день; курс 21 день, 4–6 курсов, далее камрелизумаб 200 мг каждые 3 недели до прогрессирования или непереносимой токсичности.

При невозможности химиоиммунотерапии проводят комбинированную ХТ или монохимиотерапию; число курсов определяется переносимостью и эффективностью.

Режимы комбинированной ХТ

1. карбоплатин AUC 5–6 + #паклитаксел 175 мг/м² в 1-й день, курс 21 день;
2. цисплатин 75 мг/м² + #доцетаксел 75–100 мг/м² в 1-й день, курс 21 день;
3. цисплатин 100 мг/м² в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни, курс 21 день;
4. карбоплатин AUC 5 в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м² 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели;
5. #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни + цисплатин 80 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели.

Режимы монохимиотерапии

1. цисплатин 100 мг/м², курс 21 день;
2. #паклитаксел 80 мг/м² еженедельно;
3. #доцетаксел 100 мг/м² в 1-й день, курс 21 день;
4. фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни, курс 21 день;
5. #метотрексат 40 мг/м² 1 раз в неделю;
6. #капецитабин 1250 мг/м² внутрь 2 раза в день в 1–14-й дни, перерыв 1 неделя, курс 21 день;
7. #гемцитабин 1000 мг/м² в 1, 8 и 15-й дни 1 раз в 28 дней.

Во 2-й линии применяют один из этих режимов, пембролизумаб при MSI или CPS более 1 либо ниволумаб, если 1-я линия не содержала камрелизумаб.

4.5 Профилактика и лечение осложнений

При угрозе или состоявшемся кровотечении из опухоли или метастатических узлов выполняют ангиографию наружной сонной артерии и при отсутствии противопоказаний селективную и суперселективную эмболизацию сосудов опухоли.

При оценке риска кровотечения учитывают:

1. размеры опухоли и переход на соседние структуры;
2. изъязвление опухоли;
3. полость в области опухоли или рецидива;
4. близость к ветвям сонной артерии;
5. незаживающую рану;
6. состоявшееся кровотечение из опухоли.

На фоне противоопухолевой лекарственной терапии проводят профилактику и лечение осложнений по КР Российского общества клинической онкологии

1. тошнота и рвота;
2. фебрильная нейтропения и инфекционные осложнения;
3. гепатотоксичность;
4. сердечно-сосудистые осложнения;
5. кожные реакции;
6. нефротоксичность;
7. иммуноопосредованные нежелательные явления;
8. мукозиты;
9. анемия;
10. синдром анорексии-кахексии;
11. экстравазация противоопухолевых препаратов;
12. хронический болевой синдром;
13. инфузионные реакции;
14. реактивация или обострение хронических вирусных гепатитов;
15. неврологические осложнения.

Уровни убедительности по отдельным осложнениям в КР различаются (от А до С).

При длительных (свыше 6 часов) инфузиях фторурацила или неудовлетворительном состоянии периферических вен рекомендуется установка порта в центральную вену и инфузионных помп.

4.6 Медицинская реабилитация

До начала лечения проводят профилактическую гимнастику и обучение тактике глотания, чтобы уменьшить нарушения глотания на фоне противоопухолевой терапии.

Перед ЛТ или ХЛТ пациента осматривает стоматолог, который сопровождает его на всех этапах лечения и реабилитации.

В постлучевом периоде облучённые ткани очень ранимы: в ранние сроки инвазивные диагностические процедуры и биопсию без крайней необходимости не выполняют.

Удаление зубов в зоне облучения является частой причиной лучевого остеомиелита, поэтому по возможности ограничиваются консервативными методами, а удаление выполняют только при необходимости, на фоне антибиотикотерапии.

Нутритивно-метаболическую реабилитацию перед операцией проводят **не менее 7 суток**.

Показания к нутритивной поддержке при планировании хирургического лечения

1. непреднамеренная потеря **10% массы тела и более** за 6 месяцев;
2. индекс массы тела **менее 20 кг/м²**;
3. гипопротеинемия **менее 60 г/л** или гипоальбуминемия **менее 30 г/л**;
4. ухудшение возможности приёма пищи за последнюю неделю.

Показания к нутритивной поддержке при химиотерапии

1. индекс массы тела **менее 20 кг/м²**;
2. потеря **более 5% массы тела** за 6 месяцев;
3. гипопротеинемия **менее 60 г/л** или гипоальбуминемия **менее 30 г/л**;
4. невозможность адекватного питания через рот;
5. энтеропатия средней и тяжёлой степени.

Лучевой дерматит

1. **профилактика**: низкоинтенсивное лазерное облучение кожи, начиная **через 3 дня** после начала ЛТ, 3 дня в неделю;
2. **лечение**: с появления дерматита до полного стихания реакции дерматопротекторы и ранозаживляющие местные средства (гели, мази).

При болевом синдроме, вызванном лучевыми повреждениями, назначают местные анестетики и системные анальгетики, при необходимости опиоиды, в том числе трансдермальные.

Обезболивание при раке носоглотки проводят по КР «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи».

При ЛТ или ХЛТ регулярно контролируют нутритивный статус по шкалам MUST, NRS 2002 и корригируют его специализированным питанием.

При высоком риске нарушения питания (например, ХЛТ при местно-распространённом раке глотки) рассматривают профилактическую нутритивную поддержку.

Энтеральное питание начинают, если питание через рот покрывает менее 60% потребности **в течение 10 дней**; потеря более 10% исходной массы тела также является показанием. Предпочтителен сиппинг высокобелковыми смесями; при невозможности — назогастральный зонд (при сроке стояния **до 3–4 недель**) или гастростомия. Потребность в белке составляет не менее 1,2–2 г/кг/сут, в энергии — 25–30 ккал/кг/сут.

При болевом синдроме на фоне ЛТ или ХЛТ показана консультация врача по паллиативной медицинской помощи.

На фоне ХЛТ для профилактики и лечения мукозита полости рта и глотки применяют низкоинтенсивное лазерное излучение на область дёсен.

На фоне химиотерапии рекомендуется раннее начало физических нагрузок для профилактики саркопении, уменьшения слабости и улучшения качества жизни.

Реабилитация на фоне химиотерапии и ХЛТ

1. ЛФК: аэробные упражнения средней интенсивности в сочетании с упражнениями на сопротивление;
2. упражнения на тренировку баланса при полинейропатии;
3. низкоинтенсивная лазеротерапия и переменное магнитное поле при периферической полинейропатии;
4. аппараты для профилактики алопеции;
5. низкоинтенсивное лазерное излучение на область дёсен для профилактики и лечения мукозита полости рта.

5. Диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации и выписке

5.1 Диспансерное наблюдение

Сроки контрольных обследований после лечения

Исследование	Первые 2 года	3–5-й год	После 5 лет
Осмотр и сбор жалоб	1-й год: **каждые 1–3 месяца**; 2-й год: **каждые 2–6 месяцев**	**1 раз в 4–8 месяцев**	ежегодно или при появлении жалоб
Фиброларингоскопия (если адекватный осмотр зоны интереса невозможен)	**каждые 3 месяца**	каждые 4–8 месяцев	1 раз в год
УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон	**каждые 1–3 месяца**	каждые 4–8 месяцев	1 раз в год
КТ или МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием	**каждые 1–3 месяца**	каждые 4–8 месяцев	1 раз в год
КТ органов грудной полости (при невозможности прицельная рентгенография)	каждые 6 месяцев	каждые 6 месяцев	1 раз в год

У пациентов с высоким риском рецидива интервалы между обследованиями сокращают.

Объём обследования по разделу 5 КР

1. анамнез и физикальное обследование;
2. КТ или МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием;
3. эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа и носоглотки;
4. КТ органов грудной полости **каждые 12 месяцев**;
5. ПЭТ всего тела **не ранее чем через 1 год** после окончания ЛТ;
6. ТТГ в крови **каждые 6–12 месяцев**, если облучали шею.

При появлении жалоб или возобновлении прежних симптомов пациент должен незамедлительно обратиться к врачу, не дожидаясь планового визита.

При симптомах рецидива показана ПЭТ-КТ с ФДГ или КТ органов грудной и брюшной полостей с контрастированием, при их невозможности рентгенография органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости.

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой врач направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи или первичный онкологический кабинет.

Тактику лечения определяет онкологический консилиум с участием онкологов и радиотерапевта.

Показания к госпитализации

1. **экстренная**: осложнения онкологического заболевания или его лечения;
2. **плановая**: сложные интервенционные диагностические вмешательства, специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в круглосуточном или дневном стационаре.

5.3 Показания к выписке

1. завершение курса или этапа лечения при отсутствии осложнений, требующих коррекции в стационаре;
2. отказ пациента или законного представителя от лечения в стационаре при отсутствии осложнений, требующих коррекции в стационаре;
3. несоблюдение предписаний или правил внутреннего распорядка, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих;
4. необходимость перевода в другую медицинскую организацию по профилю.

Факторы прогноза

1. размеры и распространённость первичной опухоли;
2. степень дифференцировки опухоли;
3. метастазы в лимфоузлах шеи (вдвое снижают выживаемость);
4. экстранодальное распространение опухоли.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак носоглотки»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 04.08.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2029 года
Код в рубрикаторе	535_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 3.1 при стадии T2N0M0 рекомендована самостоятельная ХЛТ, а следующий пункт для «T2–T4, любого N» рекомендует ХЛТ с адъювантной или индукционной химиотерапией: стадия T2N0 подпадает под оба пункта.
- Число циклов адъювантной ХТ после ХЛТ в тексте указано по-разному: «2 цикла» в разделе 3.1 и «3 цикла» в схемах раздела 3.3.
- Сроки наблюдения расходятся: в разделе 2.4.3 фиброларингоскопия — «каждые 3 месяца в течение первых двух лет…, каждые 2–6 месяцев в течение 2 лет», КТ органов грудной полости — каждые 6 месяцев до 5 лет; в разделе 5 КТ органов грудной полости — каждые 12 месяцев.

Клинические рекомендации

Рак носоглотки у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C11** — Злокачественное новообразование носоглотки
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/66_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 24.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рак носоглотки (назофарингеальная карцинома, НФК) является злокачественным эпителиальным новообразованием носоглотки; у детей этиологическим фактором почти всегда является вирус Эпштейна — Барр.
- Ведущим симптомом является одно- или двусторонняя лимфаденопатия шеи, которая выявляется раньше симптомов опухоли носоглотки.
- Всем пациентам при первичном приёме показан осмотр оториноларинголога: при задней риноскопии выявляются опухолевые массы, перекрывающие хоаны, при отоскопии картина экссудативного отита или тубоотита.
- Диагноз подтверждают биопсией опухоли носоглотки под контролем эндоскопии или биопсией изменённого шейного лимфоузла с иммуногистохимическим исследованием.
- Основу лечения составляют системная химиотерапия и лучевая терапия в специализированном детском онкологическом центре.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Рак носоглотки (назофарингеальная карцинома) представляет собой злокачественное эпителиальное новообразование носоглотки.

2.2 Этиология и эпидемиология

У детей и подростков вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ) является этиологическим фактором в подавляющем большинстве случаев: его серологические признаки выявляются у 98% больных, ДНК вируса определяется в клетках опухоли.

В ряде случаев определение циркулирующей ДНК ВЭБ может помочь

1. в дифференциальной диагностике;
2. в оценке прогноза (он ухудшается с ростом вирусной нагрузки);
3. в мониторинге эффекта лечения.

Имеет значение и генетическая предрасположенность (варианты HLA).

Злокачественные опухоли носоглотки составляют 1–3% злокачественных новообразований у детей. До 10 лет НФК почти не встречается; заболеваемость в 10–14 лет составляет 0,8, в 15–19 лет 1,3 на 1 млн в год.

2.3 Клиническая картина

Ведущим симптомом является одно- или двусторонняя лимфаденопатия, которая обнаруживается раньше симптомов опухоли в носоглотке.

Местные симптомы

1. носовые кровотечения, заложенность носа, выделения из носа;
2. отоалгия и рецидивирующие средние отиты из-за блокады устьев слуховых труб;
3. головная боль;
4. тризм при распространении опухоли на крыловидные и (или) жевательные мышцы.

Условное деление симптомов на четыре группы

1. носовые;
2. ушные;
3. неврологические;
4. метастатические.

Ранние симптомы (носовые и ушные) обусловлены ростом опухоли в пределах носоглотки. Неврологические симптомы и регионарные метастазы указывают на выход процесса за пределы органа; метастазы в лимфоузлы появляются в первые месяцы болезни. По мере роста опухоли появляются слизисто-гнойные выделения, в далеко зашедших стадиях ихорозный запах, примесь крови, некротические массы, спонтанные носовые кровотечения.

2.4 Классификация

Гистологические типы НФК (ВОЗ, 2005)

1. тип I: плоскоклеточный ороговевающий рак;
2. тип IIa: дифференцированный плоскоклеточный неороговевающий рак;
3. тип IIb: недифференцированный плоскоклеточный неороговевающий рак;
4. тип III: недифференцированная карцинома;
5. тип IV: базалоидный плоскоклеточный рак.

Символ T

T	Первичная опухоль (UICC/AJCC, 8-е издание)
T0	опухоль не обнаружена, но в увеличенных лимфоузлах выявлены клетки НФК, ассоциированные с ВЭБ
T1	носоглотка, ротоглотка или полость носа без окологлоточного распространения
T2	распространение в парафарингеальное пространство, поражение прилегающих мягких тканей
T3	распространение на костные структуры (основание черепа, шейный позвонок) и (или) придаточные пазухи носа
T4	внутричерепное распространение, поражение черепных нервов, гипофаринкса, орбиты, обширное поражение мягких тканей

1. N1: односторонние шейные, одно- или двусторонние заглоточные лимфоузлы не более 6 см выше перстневидного хряща;
2. N2: двустороннее поражение лимфоузлов не более 6 см выше перстневидного хряща;
3. N3: лимфоузлы более 6 см и (или) ниже перстневидного хряща.

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
I / II / III	T1N0 / T1–2N0–1 / T1–3N2, T3N0–1
IVA / IVB	T1–3N3, T4N0–2 / любая T и N, M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Всех детей с подозрением на опухоль направляют в детские онкологические центры.

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза;
2. физикального обследования;
3. лабораторных исследований;
4. инструментального обследования;
5. прижизненного патологоанатомического исследования.

3.2 Жалобы и анамнез

Подробный сбор анамнеза при первичном приёме: семейный анамнез, развитие ребёнка от рождения, доброкачественные и злокачественные опухоли у членов семьи. Жалобы уточняют при каждом приёме онколога, перед каждым курсом химиотерапии и при оценке ответа.

3.3 Осмотр оториноларинголога

Показания

1. все пациенты при первичном приёме: оценка распространения опухоли.

Диагностические признаки

1. наружный нос: возможна деформация в области наружного носа и в проекции околоносовых пазух;
2. передняя риноскопия: опухолевые массы в задних и верхних отделах полости носа;
3. задняя риноскопия: опухолевые массы в носоглотке, частично или полностью перекрывающие хоаны;
4. осмотр ротоглотки: при росте опухоли в ротоглотку смещение кпереди и асимметрия мягкого нёба, гнусавость, при больших размерах опухоли затруднение дыхания;
5. отоскопия: картина хронического экссудативного отита или тубоотита.

При каждом приёме выполняется пальпация шейных и надключичных лимфоузлов. Поражение шейных лимфоузлов наблюдается в 90% случаев НФК, отдалённые метастазы у детей не более чем в 25–30%.

При болевом синдроме в области лица и отоалгии показано исследование черепных нервов (электродиагностика лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц).

3.4 Антитела к вирусу Эпштейна — Барр

При первичном приёме, при оценке ответа и в динамическом наблюдении определяют антитела к капсидному (VCA), раннему (EA) и ядерному (NA) антигенам ВЭБ в крови для оценки активности инфекции. Титры IgG VCA и D-EA, как правило, повышаются и снижаются соответственно активности болезни.

Лабораторные исследования при каждом этапе

1. общий (клинический) анализ крови развёрнутый;
2. биохимический анализ крови (ЛДГ, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, билирубин, щелочная фосфатаза, белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, электролиты);
3. коагулограмма;
4. общий анализ мочи;
5. скорость клубочковой фильтрации.

3.5 Магнитно-резонансная томография головы и шеи

Показания

1. все этапы: первичное обследование, оценка ответа, динамическое наблюдение, подозрение на рецидив.

Выполняется МРТ мягких тканей головы и шеи с внутривенным контрастированием на томографах 1,0–3,0 Тл.

Оценивают

1. размер, объём и распространённость опухоли;
2. связь опухоли с сосудами и нервами;
3. изменения костей и васкуляризацию;
4. регионарные лимфоузлы.

3.6 Компьютерная томография

Показания

1. КТ мягких тканей головы с контрастированием: оценка деструкции костей черепа на всех этапах обследования и наблюдения.

Показания

1. КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием: все пациенты, исключение метастатического поражения лёгких.

3.7 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи

Показания

1. все этапы: первичное обследование, оценка ответа, динамическое наблюдение, подозрение на рецидив или прогрессию.

3.8 Позитронная эмиссионная томография, совмещённая с КТ (ПЭТ-КТ)

Показания

1. все пациенты с подозрением на НФК или выявленной НФК: оценка отдалённых метастазов и динамики опухолевого процесса на фоне лечения.

Применяют туморотропные радиофармпрепараты (РФП).

3.9 Эпифарингоскопия и биопсия

Показания

1. все пациенты с подозрением на НФК или выявленной НФК: уточнение распространения опухоли на своды носоглотки.

Эпифарингоскопия позволяет осмотреть все стенки носоглотки, определить направление роста опухоли и выполнить прицельную биопсию.

Эндоскопическая картина недифференцированного рака

1. экзофитный рост с изъязвлением поверхности;
2. чаще поражены боковые стенки носоглотки с распространением в ротоглотку и даже гортаноглотку;
3. реже изолированное поражение купола носоглотки;
4. при росте кпереди опухолевые массы видны в полости носа.

Эндоскопическую эндоназальную ревизию полости носа и носоглотки сочетают с биопсией слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопии. Условия проведения зависят от возраста и состояния ребёнка:

1. дети младшего возраста: в условиях седации, с участием анестезиолога-реаниматолога;
2. старшие дети и подростки при нетяжёлом состоянии: амбулаторно под местной аппликационной анестезией.

Если при эпифарингоскопии биопсия не проведена или материал не получен, выполняют биопсию опухоли носоглотки; при клинически поражённых шейных лимфоузлах возможна биопсия изменённого лимфоузла. Морфологическая верификация диагноза необходима всем пациентам.

Патологоанатомическое исследование дополняют иммуногистохимическим: определяют панцитокератин, цитокератины, p63, маркеры ВЭБ-инфекции.

3.10 Тональная аудиометрия

Показания

1. подозрение на тугоухость.

При раке носоглотки у ближайших родственников показано генетическое консультирование.

3.11 Обследование в процессе лечения

Обследование в процессе лечения по возможности проводят теми же методами, что и первичное.

Сроки и объём

1. режим № 1: после 2, 4, 6 и 7-го курсов полихимиотерапии МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием, КТ грудной полости с болюсным контрастированием, количественное определение ДНК ВЭБ методом ПЦР в крови; ПЭТ-КТ после 4 и 7-го курсов при инициальных отдалённых метастазах или подозрении на их появление;
2. режимы № 2 и 3: **не ранее 15 дней** от начала последнего (3-го или 4-го) курса индукции МРТ головы и шеи с контрастированием, КТ грудной полости, количественное определение ДНК ВЭБ методом ПЦР, ПЭТ-КТ при отдалённых метастазах или подозрении на них.

Объём контрольных обследований определяют индивидуально.

3.12 Оценка ответа на лечение

Динамику первичного и метастатических очагов оценивают по критериям RECIST 1.1.

1. полный ответ: исчезновение всех очагов;
2. частичный ответ: уменьшение суммы диаметров не менее чем на 30%;
3. прогрессия: увеличение на 20% и более или новые очаги;
4. стабилизация: все остальные случаи.

Определения ответа на лечение (раздел «Термины и определения»)

1. полный ответ: исчезновение всех очагов, короткая ось ранее увеличенных лимфоузлов менее 10 мм;
2. частичный ответ: уменьшение суммы диаметров очагов не менее чем на 30%;
3. прогрессия: новый опухолевый очаг или увеличение измеряемого очага более чем на 20%;
4. рецидив: новые очаги после достигнутого полного ответа.

3.13 Обследование перед завершением терапии

После лучевой терапии МРТ и КТ головного мозга и шеи выполняют через **6 недель**, ПЭТ-КТ **не ранее чем через 3 месяца**.

Объём обследования после этапа лучевой терапии

1. детальное физикальное и неврологическое обследование, по показаниям осмотр узких специалистов;
2. общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, коагулограмма;
3. эхокардиография, электрокардиограмма;
4. по показаниям: электроэнцефалография, тональная аудиометрия, биомикроскопия глазного дна, цитологическое исследование спинномозговой жидкости, гормональный статус.

---

4. Лечение

Лечение мультидисциплинарное и проводится под контролем специализированных центров с опытом лечения НФК. Основу терапии составляют системная химиотерапия и лучевая терапия; КР приводит три режима, показавших эффективность у детей и подростков.

Показания к началу индукционной химиотерапии

1. гистологическая верификация диагноза;
2. лейкоциты выше 2×10^9/л (для режимов 2 и 3 гранулоциты выше $0{,}75\times10^9$/л), тромбоциты выше 75×10^9/л;
3. нет декомпенсации хронических заболеваний и тяжёлых органных дисфункций;
4. нет (неконтролируемых) инфекционных осложнений;
5. нет аллергических реакций на препараты режима.

4.1 Режимы лечения

Режимы лечения НФК у детей

Режим	Состав
№ 1: химиотерапия + лучевая терапия	4 курса индукции (#винбластин + #циклофосфамид + доксорубицин + #блеомицин) через 21–28 дней, при полном или частичном ответе 4 курса консолидации, лучевая терапия
№ 2: химиотерапия + химиолучевая терапия	стадии II–IVA: 3 курса индукции #фторурацил + цисплатин через 21–28 дней (стадия IVB: 4 курса), затем лучевая терапия с цисплатином
№ 3: химиотерапия + химиолучевая терапия	стадии II–IVA: 3 курса индукции #гемцитабин + цисплатин через 21 день; стадия IVB: 4 курса с добавлением #пембролизумаба (по решению федерального консилиума)
Стадия I	лучевая терапия без индукционной химиотерапии: СОД 66,6 Гр на опухоль и профилактически 45 Гр на регионарные лимфоузлы

Режим № 1: индукция (табл. 2 КР)

1. #винбластин 5 мг/м² струйно в 1, 8, 15-й дни;
2. #циклофосфамид 600 мг/м² за 1 час в 1-й день;
3. доксорубицин 20 мг/м² за 1 час в 1, 8-й дни;
4. #блеомицин 10 мг/м² за 1 час во 2, 4-й дни; при суммарной дозе 300 мг/м² его исключают.

С 7-го дня курса вводится #оксодигидроакридинилацетат натрия 5 мг/кг в сутки через 48 часов, 5–7 инъекций; всего 4 курса на фоне первых 4 курсов ПХТ и ЛТ.

Консолидация (табл. 3 КР)

1. #винбластин 5 мг/м² в 1, 8, 15-й дни;
2. #циклофосфамид 500 мг/м² в 1, 8-й дни;
3. #дактиномицин в 1-й день (в КР указано «1200 мг/м²», максимальная разовая доза 2,5 мг; во время ЛТ не вводится).

Интервалы между курсами 21–28 дней.

Лучевая терапия режима № 1

1. первичная опухоль: СОД 50 Гр;
2. регионарные лимфоузлы: 45,6 Гр при метастатическом поражении, 36 Гр без признаков поражения;
3. метастазы в лёгких: облучение лёгких 12 Гр;
4. одиночные метастазы в костях и мягких тканях: до 36–50 Гр.

Режимы № 2 и 3: индукция

1. #фторурацил 1000 мг/м² инфузией 24 часа в 1–5-й дни + цисплатин 100 мг/м² за 6 часов в 1-й день (режим № 2);
2. #гемцитабин 1000 мг/м² за 30 минут в 1, 8-й дни + цисплатин 80 мг/м² за 4 часа в 1-й день (режим № 3);
3. при стадии IVB в режиме № 3 дополнительно #пембролизумаб 2 мг/кг (не более 200 мг) в 1-й день.

Лучевая терапия режимов № 2 и 3

1. первичная опухоль и ретрофарингеальные лимфоузлы: РОД 1,8 Гр, СОД 54 Гр (при локальной прогрессии на фоне ПХТ 66,6 Гр, на остаточную опухоль до 59,4 Гр);
2. лимфоколлекторы шеи IB–V: 45 Гр, поражённые 54 Гр, остаточные до 59,4 Гр;
3. стадии II–IVA: в первые 3 и последние 3 дня ЛТ цисплатин 20 мг/м² за 1 час.

4.2 Поддерживающая терапия и рецидив

1. стадия I: после лучевой терапии наблюдение без поддерживающей терапии;
2. стадии II–IVB: #интерферон бета-1b 100 тыс. МЕ/кг подкожно 3 раза в неделю **6 месяцев**.

При прогрессии или рецидиве, а также при больших метастатических лимфоузлах шеи со сдавлением жизненно важных структур (решение о шейной лимфодиссекции) показано обращение в федеральные центры.

Сопроводительная терапия

1. оценка и коррекция нутритивного статуса;
2. профилактика и лечение тошноты и рвоты;
3. гемотрансфузионная поддержка при анемии, кровотечении, высоком риске геморрагического синдрома;
4. имплантируемый порт или центральный венозный катетер;
5. рациональная антибактериальная терапия инфекционных осложнений.

4.3 Медицинская реабилитация

Реабилитация начинается на этапе первичной полихимиотерапии и продолжается на всех этапах динамического наблюдения; кратность реабилитации составляет **2–3 раза в год** и может быть увеличена в зависимости от психосоматического статуса.

При жалобах на снижение слуха и при наследственной тугоухости показана консультация сурдолога-оториноларинголога, при необходимости сурдологическая коррекция.

После специального лечения показаны консультация детского эндокринолога и диспансерное наблюдение для своевременной коррекции гипофункции щитовидной железы и гипофиза.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Обследование после окончания лечения

Исследование	1-й год	2-й год	3-й год	4–5-й год
Осмотр, анализы крови и мочи, УЗИ шеи, МРТ и КТ головы и шеи	1 раз в 3 мес.	1 раз в 4 мес.	1 раз в 6 мес.	1 раз в год
Проба Реберга (клиренс креатинина)	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год
КТ органов грудной полости	1 раз в 3 мес.	1 раз в 6 мес.	1 раз в 6 мес.	1 раз в год
ПЭТ-КТ; ЭКГ и ЭхоКГ; тональная аудиометрия	1 раз в год	1 раз в год	по показаниям	по показаниям

При I–II стадии ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозой необязательна.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к плановой госпитализации в детское онкологическое отделение

1. биопсия опухоли носоглотки или изменённого шейного лимфоузла для морфологической верификации диагноза;
2. курсы химиотерапии;
3. лучевая терапия.

Показания к экстренной госпитализации

1. фебрильная нейтропения;
2. стоматит 3–4 степени;
3. токсичность 2–4 степени, требующая коррекции в условиях стационара.

Показания к выписке

1. отсутствие признаков токсичности химиолучевой терапии 2–4 степени;
2. отсутствие показаний к химиолучевой терапии (перерыв между курсами или этапами лечения);
3. отказ родителей, законных представителей или пациента **старше 14 лет** от специального лечения;
4. показания к симптоматической терапии при неэффективности специального лечения и отсутствии токсичности 2–4 степени.

Амбулаторное лечение и дневной стационар

1. диагностика на этапе постановки диагноза и между курсами химиотерапии: амбулаторно;
2. химиотерапия детям старшего возраста и подросткам: в дневном стационаре;
3. лучевая терапия: амбулаторно или в дневном стационаре, если не требуется анестезиологическое сопровождение и нет осложнений, требующих сопроводительной терапии;
4. дети дошкольного и младшего школьного возраста: химио- и лучевая терапия только в специализированных отделениях стационара.

При развитии осложнений ребёнка переводят на стационарное лечение.

Неблагоприятные прогностические факторы

1. отдалённые метастазы;
2. снижение доз химиопрепаратов;
3. отказ от лучевой терапии;
4. интервалы между курсами более 28 дней;
5. инфекционные осложнения;
6. распространение опухоли на латеральную крыловидную мышцу.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак носоглотки»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 15.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	66_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 3 (консолидация режима № 1) доза #дактиномицина указана как «1200 мг/м^2», тогда как максимальная разовая доза составляет 2,5 мг; вероятно, имеются в виду микрограммы (мкг/м^2).

Клинические рекомендации

Рак полости носа и придаточных пазух

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C30** — Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха **C31** — Злокачественное новообразование придаточных пазух
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/3_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рак полости носа и придаточных пазух представляет собой злокачественную опухоль из элементов слизистой оболочки полости носа и пазух.
- Поводом заподозрить рак является заложенность носа, не поддающаяся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**. Первыми проявлениями бывают также выделения из носа, боль, экзофтальм при распространении в орбиту.
- Ранний рак решётчатого лабиринта в большинстве случаев выявляют при гистологическом исследовании материала после операций по поводу предполагаемых неопухолевых процессов (полипозный этмоидит, полипы полости носа).
- Диагноз верифицируется биопсией слизистой оболочки полости носа. Распространённость оценивают по КТ лицевого черепа и шеи с контрастированием и (или) МРТ, УЗИ лимфоузлов шеи.
- При подозрении на рак пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи, консультация проводится **не позднее 5 рабочих дней**.
- Основным методом лечения при Т1–Т4а является хирургическое вмешательство с последующей лучевой (ЛТ) или химиолучевой терапией (ХЛТ) по показаниям. Тактику определяет онкологический консилиум.
- Плановая госпитализация показана для специализированного противоопухолевого лечения, а экстренная при осложнениях заболевания или лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Верхняя стенка полости носа представлена сетевидной (решётчатой) пластинкой, передней стенкой основной пазухи, передними клетками решётчатого лабиринта; внутренняя — перегородкой носа; наружная — медиальной стенкой верхнечелюстной пазухи; задняя — хоанами; передняя — грушевидным отверстием.

Радикальная операция (R0) — удаление поражённого органа в пределах здоровых тканей вместе с зонами регионарного метастазирования без остаточных проявлений опухолевого процесса.

2.2 Этиология и эпидемиология

Этиологические факторы

1. хронические воспалительные заболевания: хронические синуситы, вазомоторный ринит, бронхиальная астма, инвертированная папиллома;
2. неблагоприятные факторы внешней среды;
3. канцерогены физической и химической природы, особенно на вредном производстве.

Злокачественные опухоли полости носа и пазух составляют 1,4% всех злокачественных опухолей; в 2021 г. в России — 1012 новых случаев.

2.3 Клиническая картина

Первые проявления

1. заложенность носа;
2. выделения из полости носа;
3. болевой синдром;
4. экзофтальм при распространении в орбиту.

В 70% случаев опухоли эпителиальные: плоскоклеточный рак составляет 80%, аденокарцинома 6%, эстезионейробластома 10%, редко встречается меланома.

2.4 Классификация TNM (8-е издание, 2017)

Символ T: верхнечелюстная пазуха

T	Верхнечелюстная пазуха
T1	ограничена слизистой оболочкой без эрозии или деструкции кости
T2	эрозия или разрушение кости, включая твёрдое нёбо и (или) средний носовой ход, без распространения на заднюю стенку пазухи и крыловидные отростки
T3	задняя стенка пазухи, подкожная клетчатка, дно или медиальная стенка орбиты, крыловидная ямка, решётчатые клетки
T4a	передний край орбиты, кожа щеки, крыловидные отростки, подвисочная ямка, сетевидная пластинка, основная или лобная пазуха
T4b	купол орбиты, твёрдая мозговая оболочка, мозг, средняя черепная ямка, черепные нервы (кроме верхнечелюстной ветви тройничного), носоглотка, скат

Символ T: полость носа и решётчатый лабиринт

T	Полость носа, клетки решётчатого лабиринта
T1	одна сторона полости носа или решётчатых клеток, с эрозией кости или без
T2	две стороны полости носа и прилежащие участки в пределах полости носа и решётчатых клеток
T3	медиальная стенка или дно орбиты, верхнечелюстная пазуха, нёбо, решётчатые клетки
T4a	передние структуры орбиты, кожа носа или щёк, минимально передняя черепная ямка, крыловидные отростки, основная или лобная пазуха
T4b	купол орбиты, твёрдая мозговая оболочка, головной мозг, средняя черепная ямка, черепные нервы (кроме верхнечелюстной ветви тройничного), носоглотка, скат

Символ N (регионарные лимфатические узлы)

1. **N1**: один ипсилатеральный лимфоузел до 3 см без экстранодального распространения (ENE−);
2. **N2**: до 3 см с ENE+ или 3–6 см ENE−; несколько ипсилатеральных или контралатеральные до 6 см ENE−;
3. **N3**: более 6 см ENE− или любой с ENE+, кроме N2a.

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
I	T1N0
II	T2N0

Стадия	TNM
III	T3N0 или T1–T3N1
IVA	T4a N0–N2; T1–T3 N2
IVB	любая T N3; T4b любая N
IVC	M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: заложенность носа, не поддающаяся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**;
2. осмотра и пальпации образования, прилежащих тканей и регионарных лимфоузлов;
3. цитологии соскоба, мазков, пунктата опухоли и лимфоузлов;
4. патологоанатомического исследования биопсийного материала;
5. инструментального обследования: УЗИ шеи, КТ лицевого черепа и шеи с контрастом и (или) МРТ, ПЭТ-КТ, фиброларингоскопия по показаниям.

3.2 Жалобы, анамнез и осмотр

Тщательный сбор жалоб и анамнеза необходим каждому пациенту для выбора тактики лечения.

Физикальное обследование включает осмотр и бимануальную пальпацию очага и регионарных лимфоузлов, оценку нутритивного статуса.

3.3 Биопсия слизистой оболочки полости носа

Диагноз верифицируется биопсией слизистой оболочки полости носа. При верифицированной опухоли определяют гистологический тип и степень дифференцировки.

При сомнительном результате обязательна повторная биопсия в достаточном объёме с иммуногистохимией; при повторно отрицательном результате биопсию повторяют при убедительных клинических и (или) рентгенологических признаках злокачественной опухоли.

3.4 КТ, МРТ, УЗИ, ПЭТ-КТ

Распространённость опухоли оценивают по КТ лицевого черепа и шеи с болюсным контрастированием и (или) МРТ лицевого черепа и шеи с контрастом.

Стадирование

1. УЗИ лимфоузлов шеи и тонкоигольная биопсия изменённых узлов под УЗИ или КТ;
2. УЗИ органов брюшной полости;
3. КТ органов грудной полости (при невозможности — рентгенография лёгких);
4. при T3–T4 или N1 и более — ПЭТ-КТ или КТ грудной и брюшной полостей с контрастом;
5. фиброларингоскопия и ЭГДС по показаниям.

Через **2–3 месяца** после ЛТ или ХЛТ эффект оценивают по ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозой (ФДГ) или МРТ с контрастом.

При симптомах рецидива или установленном рецидиве показана ПЭТ-КТ; если ПЭТ-КТ или КТ грудной и брюшной полостей с контрастом недоступны, выполняют рентгенографию органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости.

3.5 Обследование перед операцией

Для оценки функционального статуса по показаниям выполняют

1. эхокардиографию;
2. холтеровское мониторирование сердечного ритма;
3. исследование функции внешнего дыхания;
4. ультразвуковую допплерографию артерий и вен нижних конечностей;
5. консультации кардиолога, эндокринолога, невролога.

3.6 Патологоанатомическое исследование операционного материала

В заключении по операционному материалу отражают

1. размер, глубину инвазии, гистологическое строение и дифференцировку;
2. лимфоваскулярную и периневральную инвазию;
3. pT, pN с числом исследованных и поражённых узлов и экстранодальным распространением;
4. состояние краёв резекции.

---

4. Лечение

4.1 Рак полости носа и клеток решётчатого лабиринта

Лечение рака полости носа и решётчатого лабиринта

Стадия	Тактика лечения
T1–T2, первично выявленный	операция, после неё ЛТ; наблюдение только при T1 с благоприятными признаками (чистые края, нет прилежания к сетевидной пластинке и медиальной стенке орбиты, высокая дифференцировка)
T3–T4a	операция на первом этапе, или ЛТ/ХЛТ, или индукционная химиотерапия (ХТ) с операцией или ХЛТ; после операции ЛТ или ХЛТ при опухоли в краях резекции и (или) внутричерепном распространении
T4b, отказ от операции или противопоказания к ней	по шкале ECOG: 0–1 балл: ХЛТ или индукционная ХТ с ЛТ; 2 балла: ЛТ ± ХТ; 3 балла: паллиативная ЛТ, монохимиотерапия или паллиативная помощь

Если диагноз установлен после неполного удаления (полипэктомия) и сохраняется остаточная опухоль, рекомендованы хирургическое удаление, ЛТ или конкурентная ХЛТ.

После операции ЛТ или одновременная ХЛТ показаны при неблагоприятных прогностических факторах

1. опухолевые клетки в краях резекции;
2. прилежание опухоли к сетевидной пластинке, медиальной стенке орбиты;
3. интракраниальное или внутриорбитальное распространение;
4. неблагоприятная гистология: низкодифференцированные опухоли, аденокистозный рак;
5. периневральная или лимфатическая инвазия.

Нерадикальная первая операция фактически является расширенной биопсией, и дальнейшее лечение проводят как при впервые установленном диагнозе. Метастазы в лимфоузлы шеи при раке полости носа и решётчатого лабиринта крайне редки; при их выявлении выполняют шейную лимфодиссекцию.

Если до операции выполнялись КТ или МРТ, нерадикальная операция может быть дополнена одной радикальной ЛТ только при формальной стадии T1–T2, без распространения на основание черепа.

Если после нерадикального удаления остаточная опухоль клинически и по данным обследования не определяется, рекомендованы ЛТ или операция с последующей ЛТ.

Наблюдение без лечения допустимо только при T1 и благоприятных признаках

1. резекция R0;
2. центральное расположение опухоли;
3. высокая дифференцировка;
4. отсутствие периневральной и лимфатической инвазии.

При синоназальной недифференцированной карциноме, низкодифференцированной эстезионейробластоме, синоназальном нейроэндокринном раке в план включают системную химиотерапию.

4.2 Рак верхнечелюстной пазухи (кроме меланомы, саркомы, лимфомы)

Лечение рака верхнечелюстной пазухи

Стадия	Тактика лечения
T1–T2 N0 (кроме аденокистозного рака)	радикальная операция и наблюдение; при периневральной, сосудистой, лимфатической инвазии ЛТ или ХЛТ; при положительных краях резекция и ЛТ, при повторной нерадикальной операции одновременная ХЛТ
T1–T2 N0, аденокистозный рак	радикальная операция и ЛТ; наблюдение возможно при R0 и отсутствии периневральной инвазии
T3–T4a N0	радикальная операция, затем ЛТ; при опухоли в краях резекции ХЛТ
T1–T4a N+	удаление опухоли и расширенная шейная лимфаденэктомия, затем ЛТ; при опухоли в краях или экстракапсулярном распространении ХЛТ
T4b, отказ от операции	по шкале ECOG: 0–1 балл: ХЛТ или индукционная ХТ с ЛТ; 2 балла: ЛТ ± ХТ; 3 балла: паллиативная ЛТ, монохимиотерапия или паллиативная помощь

1. **рецидив без предшествующей ЛТ**: операция, ХЛТ или индукционная ХТ с ХЛТ;
2. **рецидив после ЛТ**: операция с обсуждением повторной ЛТ, при невозможности операции повторная ЛТ и противорецидивная ХТ;
3. **рецидив с отдалёнными метастазами**: по шкале ECOG, как при T4b.

Если при плановом гистологическом исследовании после операции выявлены

1. прорастание опухолью капсулы лимфоузла, периневральная инвазия, опухолевые эмболы в сосудах: показана одновременная ХЛТ;
2. положительные края резекции: рассматривают повторную операцию или ЛТ.

Шкала ECOG

Балл	Общее состояние
0	полностью активен, способен выполнять всё, как до заболевания (90–100 баллов по шкале Карновского)
1	выполняет сидячую работу, например лёгкую домашнюю или канцелярскую (70–80 баллов по шкале Карновского)
2	лечится амбулаторно, способен к самообслуживанию, но не может выполнять работу; более 50% времени бодрствования активен, в вертикальном положении (50–60 баллов по шкале Карновского)
3	способен лишь к ограниченному самообслуживанию, проводит в кресле или постели более 50% времени бодрствования (30–40 баллов по шкале Карновского)

Балл	Общее состояние
4	инвалид, совершенно не способен к самообслуживанию, прикован к креслу или постели (10–20 баллов по шкале Карновского)

4.3 Лучевая терапия

До лечения всех пациентов оценивает радиотерапевт, предпочтительно специализирующийся на опухолях головы и шеи: адекватность верификации, стадирования и визуализации, отсутствие синхронной первичной опухоли, функциональный статус и возможность ЛТ или ХЛТ.

1. **самостоятельная ЛТ**: на опухоль и метастазы в лимфоузлах 70 Гр (1,8–2,0 Гр за фракцию) **7 недель**, на неизменённые лимфоузлы 50 Гр;
2. **послеоперационная ЛТ**: на ложе опухоли и поражённые узлы 60–66 Гр, на неизменённые узлы 50 Гр; интервал после операции **до 6 недель**, **не более 3 месяцев**.

Послеоперационная ХЛТ

1. ЛТ на первичный очаг и клинически определяемые метастазы 66–70 Гр (2,0 Гр за фракцию) за **6–7 недель**, на локорегионарную область 46–54 Гр;
2. цисплатин 100 мг/м^2 на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни ЛТ или еженедельно #40 мг/м^2, суммарно 300 мг/м^2 за курс ЛТ;
3. при противопоказаниях к препаратам платины: цетуксимаб.

Противопоказания к препаратам платины

1. хроническая почечная недостаточность, СКФ менее 50–60 мл/мин;
2. возраст **старше 65 лет**;
3. выраженная почечная, сердечно-сосудистая, неврологическая, печёночная патология;
4. ослабленное состояние (ECOG более 1).

Паллиативную ЛТ применяют для облегчения симптомов при невозможности радикального лечения: 50 Гр по 2,5 Гр или 30 Гр по 3 Гр.

4.4 Лекарственное лечение

Индукционная ХТ с последующей одновременной ХЛТ: доцетаксел + цисплатин + фторурацил, 2–3 курса с интервалом 3 недели.

Индукционная ХТ при нейроэндокринной опухоли и низкодифференцированной эстезионейробластоме

1. карбоплатин AUC 5–6 + #этопозид 100 мг/м^2 в 1–3-й дни;
2. цисплатин 75 мг/м^2 + #этопозид 100 мг/м^2 в 1–3-й дни;
3. #циклофосфамид + доксорубицин + #винкристин;
4. цисплатин 50 мг/м^2 + доксорубицин 50 мг/м^2 + #циклофосфамид 500 мг/м^2 в 1-й день каждые 3 недели.

Одновременная ХЛТ

1. ЛТ на первичный очаг и клинически определяемые метастазы 70 Гр (2,0 Гр за фракцию) за **6–7 недель**, на неизменённые лимфоузлы 44–60 Гр;
2. цисплатин (предпочтительно) 100 мг/м^2 на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни ЛТ, суммарно 300 мг/м^2;
3. или еженедельно карбоплатин AUC 1,5–2,0;
4. или цетуксимаб 400 мг/м^2 за неделю до начала ЛТ, затем 250 мг/м^2 еженедельно во время ЛТ.

При рецидивных, первично неоперабельных опухолях или метастатическом процессе, если одновременная ХЛТ невозможна, рекомендуется поли- или монохимиотерапия с учётом общего состояния и целей лечения; число курсов определяется переносимостью и эффективностью.

Противорецидивные режимы с цисплатином и цетуксимабом

1. PF + цетуксимаб: цисплатин 75–100 мг/м² в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза), далее 250 мг/м² еженедельно; после 6 циклов при отсутствии прогрессирования поддерживающая терапия цетуксимабом 250 мг/м² еженедельно;
2. DC + цетуксимаб: #доцетаксел 75 мг/м² + цисплатин 75 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м², далее 250 мг/м² еженедельно; после 4 циклов поддерживающая терапия цетуксимабом 500 мг/м² 1 раз в 2 недели;
3. цисплатин + цетуксимаб: цисплатин 75–100 мг/м² 1 раз в 3 недели (не более 6–8 введений) + цетуксимаб 400 мг/м², далее 250 мг/м² еженедельно до прогрессирования или непереносимой токсичности;

Противорецидивные режимы с паклитакселом, карбоплатином и цетуксимабом

1. паклитаксел + карбоплатин + цетуксимаб: #паклитаксел 100 мг/м² + карбоплатин AUC 2,5 в 1-й и 8-й дни + цетуксимаб 400 мг/м², далее 250 мг/м² еженедельно, цикл 21 день; после 6 циклов поддерживающая терапия цетуксимабом;
2. еженедельно: #паклитаксел 80 мг/м² + карбоплатин AUC 2,0 + цетуксимаб 400 мг/м², далее 250 мг/м², затем поддерживающая терапия цетуксимабом;

Противорецидивные режимы без цетуксимаба

1. PF: цисплатин 75–100 мг/м² в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели;
2. карбоплатин AUC 5 в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м² 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели, 6 циклов, возможно до 8;
3. #паклитаксел 175 мг/м² + карбоплатин AUC 5–6 в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов, возможно до 8;
4. #паклитаксел 60–80 мг/м² + карбоплатин AUC 2 еженедельно, не более 18 недель;
5. DC: #доцетаксел 75 мг/м² + цисплатин 75 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов, возможно до 8;

Иммунотерапия

1. ниволумаб: 3 мг/кг или 240 мг 1 раз в 2 недели, или 480 мг 1 раз в 4 недели, не более 2 лет (во 2-й и последующих линиях при платинорезистентных опухолях);
2. пембролизумаб: 200 мг 1 раз в 3 недели или 400 мг 1 раз в 6 недель, не более 2 лет;
3. PF + пембролизумаб: пембролизумаб 200 мг + карбоплатин AUC 5 или цисплатин 100 мг/м² + фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни 1 раз в 3 недели (6 циклов), далее пембролизумаб, всего до 35 введений.

Монотерапия при ECOG более 2 баллов

1. цисплатин 60–70 мг/м² 1 раз в 3 недели;
2. карбоплатин AUC 5–6 1 раз в 3 недели или AUC 2 еженедельно;
3. #паклитаксел 175 мг/м² 1 раз в 3 недели или 80 мг/м² еженедельно;
4. #доцетаксел 70–75 мг/м² 1 раз в 3 недели;
5. #капецитабин 2000 мг/м² внутрь в 2 приёма в 1–14-й дни, перерыв 1 неделя, или 2000 мг/сут в метрономном режиме;
6. #метотрексат 40 мг/м² еженедельно;
7. цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день 1-го курса, далее 250 мг/м² еженедельно.

4.5 Хирургическое лечение

До лечения всех пациентов оценивают хирург и онколог, специализирующиеся на опухолях головы и шеи. Первичную опухоль удаляют единым блоком с чистыми краями: чистым считается край **5 мм и более** от инвазивного края опухоли. При прилежании опухоли к нерву выполняют резекцию нерва со срочным гистологическим исследованием краёв.

Поражение структур, связанное с плохим прогнозом

1. значительное поражение крылонёбной ямки;
2. тяжёлый тризм из-за инфильтрации крыловидных мышц;
3. распространение на основание черепа;
4. охват сонной артерии на **270° и более**;
5. распространение на кожу, средостение, предпозвоночную фасцию или шейные позвонки.

Адекватным считается удаление с расстоянием от края резекции до видимой опухоли не менее 2 см или с отрицательным краем замороженного среза. Срочное исследование краёв проводят, если свободная зона менее 2 см, граница опухоли нечёткая или есть подозрение на резидуальную опухоль. Близким считается край менее 5 мм.

При угрозе кровотечения из опухоли оценивают риск и выполняют ангиографию с суперселективной эмболизацией сосудов опухоли.

Реабилитацию проводят по общим принципам реабилитации после операций и химиотерапии.

---

5. Диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации и выписке

5.1 Диспансерное наблюдение

Частота осмотров после лечения

1. 1–2-й год: **каждые 3–6 месяцев**;
2. 3–5-й год: **1 раз в 6–12 месяцев**;
3. после 5 лет: ежегодно или при жалобах.

Обследование по разделу 2.4.3 КР

1. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон: **каждые 3 месяца** в 1-й год, каждые 3–6 месяцев во 2-й, ежегодно в 3–5-й;
2. КТ или МРТ лицевого черепа и шеи: каждые 3 месяца в 1-й год, 3–6 месяцев во 2-й, далее по показаниям;
3. КТ органов грудной полости каждые 12 месяцев;
4. фиброларингоскопия и ЭГДС при жалобах; при подозрении на рецидив ПЭТ-КТ.

УЗИ органов брюшной полости: **каждые 3 месяца** в 1-й год, каждые 3–6 месяцев во 2-й, в 3–5-й год 1 раз в 6–12 месяцев.

Объём обследования по разделу 5 КР

1. анамнез и физикальное обследование;
2. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон, органов брюшной полости и малого таза **каждые 3–6 месяцев** в зависимости от риска прогрессирования;
3. рентгенография органов грудной клетки **каждые 12 месяцев**.

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой специалист направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи; консультация проводится **не позднее 5 рабочих дней**, патологоанатомическое исследование **не более 15 рабочих дней**. Тактику лечения определяет онкологический консилиум.

5.3 Показания к госпитализации

Экстренная или неотложная госпитализация

1. осложнения онкологического заболевания, требующие специализированной помощи в экстренной или неотложной форме;
2. осложнения лечения (операции, ЛТ, лекарственной терапии).

Плановая госпитализация

1. сложные интервенционные диагностические вмешательства, требующие наблюдения в круглосуточном или дневном стационаре;
2. специализированное противоопухолевое лечение (операция, ЛТ, лекарственная терапия), требующее наблюдения в круглосуточном или дневном стационаре.

5.4 Показания к выписке

1. завершение курса или этапа лечения при отсутствии осложнений, требующих коррекции в стационаре;
2. отказ пациента или законного представителя от лечения в стационаре при отсутствии осложнений, требующих коррекции в стационаре;
3. несоблюдение предписаний или правил внутреннего распорядка, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих;
4. необходимость перевода в другую медицинскую организацию по профилю.

Факторы прогноза

1. размер и распространённость опухоли, дифференцировка;
2. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
3. метастазы в лимфоузлах шеи (вдвое снижают выживаемость), экстранодальное распространение;
4. индекс Ki-67, статус краёв резекции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак полости носа и придаточных пазух»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 24.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	3_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Периодичность наблюдения в разделах 2.4.3 и 5 различается: в 2.4.3 УЗИ шеи — каждые 3 месяца в 1-й год и ежегодно в 3–5-й, в разделе 5 — каждые 3–6 месяцев; осмотры в 1–2-й год указаны как

«каждые 36 месяца» (вероятно, 3–6).

Клинические рекомендации

Рак ротоглотки

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C01** — Злокачественные новообразования основания языка **C02.4** — Язычной миндалины **C05.1** — Мягкого неба **C05.2** — Язычка **C09** — Злокачественное новообразование миндалины **C10** — Злокачественное новообразование ротоглотки **D37.0** — Губы, полости рта и глотки
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.08.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/4_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 27.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рак ротоглотки: злокачественная опухоль из элементов неороговевающего эпителия ротоглотки. Основными этиологическими факторами считаются курение (особенно в сочетании с крепким алкоголем), жевание смесей (нас, бетель) и вирус папилломы человека (ВПЧ), прежде всего 16-го и 18-го типов.
- В ранний период пациенты жалуются на неловкость при глотании и боль, которые нередко расценивают как «ангину» и проводят безуспешное противовоспалительное лечение. Метастазы на шее могут опережать проявления первичной опухоли.
- Всем пациентам биопсийный материал исследуют на ВПЧ 16-го и 18-го типов. Экспрессия белка p16 (ИГХ) обязательна к исследованию: от неё зависят стадия по TNM и тактика лечения.
- **Обследование при подозрении на рак ротоглотки**
  1. фиброларингоскопия и эзофагоскопия с биопсией;
  2. УЗИ лимфоузлов шеи с пункцией подозрительных узлов;
  3. МРТ или КТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием;
  4. КТ органов грудной полости;
  5. ПЭТ-КТ или КТ органов грудной и брюшной полостей **при стадии III и выше**.
- При ранних стадиях (**T1–2 N0 M0**) предпочтителен один метод лечения: либо лучевая терапия, либо операция. Лечение, требующее затем второго метода, нежелательно из-за суммации побочных эффектов.
- При подозрении на рак пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи (первичный онкологический кабинет); консультация проводится **не позднее 5 рабочих дней** с даты направления.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Отделы ротоглотки

1. **передняя стенка** — корень языка, валлекулы
2. **боковые стенки** — нёбные миндалины, миндаликовые ямки, передние и задние нёбные дужки, язычно-миндаликовые борозды
3. **задняя стенка** — правая и левая сторона
4. **верхняя стенка** — нижняя поверхность мягкого нёба, язычок

2.2 Эпидемиология

В 2021 г. в России зарегистрировано 2833 случая рака ротоглотки; стандартизованная заболеваемость у мужчин 2,3, у женщин 0,40 на 100 тыс. населения. Чаще всего заболевание выявляют в 40–74 года, пик приходится на 65–69 лет (5,9 на 100 тыс.). Число впервые выявленных случаев ежегодно растёт в среднем на 3,1%.

2.3 Клиническая картина

Проявления зависят от распространённости, локализации и формы роста опухоли (экзофитная, язвенная, инфильтративная). Выделяют начальный, развитой период и период запущенности. Чаще всего (64%) встречается рак нёбных миндалин.

Рак нёбной миндалины

1. в ранний период: неловкость при глотании и боль, которые принимают за «ангину»;
2. при осмотре: плотный бугристый инфильтрат с изъязвлением, опухоль может переходить на ретромолярную область, корень языка, мягкое нёбо, нёбные дужки;
3. боль иррадиирует в ухо и соответствующую половину головы;
4. при некрозе опухоли: гнилостный запах изо рта, тризм.

Другие локализации

1. **корень языка (20,8%)** — нарушение подвижности языка, сильная иррадиирующая боль, нарушение глотания; опухоль может достигать большого размера, вызывая лишь чувство «неловкости» при глотании
2. **мягкое нёбо (9,1%)** — чаще язычок и свободный край; по мере инфильтрации мышц нарушаются глотание и речь
3. **задняя стенка (5,2%)** — опухоль быстро распространяется по глотке и на подлежащие структуры

Рак ротоглотки отличается высоким метастатическим потенциалом: регионарные лимфоузлы поражены у 77–80% пациентов, чаще всего верхней глубокой яремной цепи, поднижнечелюстные и заглоточные; метастазы нередко инфильтративные. Отдалённые метастазы (лёгкие, кости и другие органы) возникают у 14–30%.

2.4 Классификация TNM (8-е издание AJCC) с учётом p16

Символ T: p16-отрицательный рак ротоглотки

T	p16-отрицательный рак
T1	опухоль до 2 см в наибольшем измерении
T2	опухоль от 2 до 4 см
T3	опухоль более 4 см или с распространением на язычную поверхность надгортанника
T4a	умеренно распространённый процесс: гортань, поверхностные мышцы языка, медиальная крыловидная мышца, твёрдое нёбо или нижняя челюсть
T4b	распространённый процесс: латеральная крыловидная мышца, крыловидная кость, боковая стенка носоглотки, основание черепа или охват сонной артерии

Переход опухоли корня языка или язычных валлекул на слизистую оболочку язычной поверхности надгортанника не означает поражения гортани.

Символ N (клинически), p16-отрицательный рак

1. **N1** — один лимфоузел на стороне поражения до 3 см, ENE отсутствует
2. **N2a** — один узел на стороне поражения более 3 и не более 6 см, ENE−
3. **N2b** — несколько узлов на стороне поражения до 6 см, ENE−
4. **N2c** — узлы с обеих сторон или с противоположной стороны до 6 см, ENE−
5. **N3a** — узел более 6 см, ENE−
6. **N3b** — любые узлы с клинически явной ENE+

Символ pN (патоморфологически), p16-отрицательный рак

1. **pN1** — один узел на стороне поражения до 3 см, ENE−
2. **pN2a** — один узел на стороне поражения до 3 см с ENE+ или более 3 и менее 6 см ENE−
3. **pN2b** — несколько узлов на стороне поражения до 6 см, ENE−
4. **pN2c** — узлы с обеих сторон или с противоположной стороны до 6 см, ENE−
5. **pN3a** — узел более 6 см, ENE−
6. **pN3b** — один ипсилатеральный узел более 3 см с ENE+, или множественные узлы с ENE+, или единственный контралатеральный узел любого размера с ENE+

Символ T: p16-положительный рак ротоглотки

T	p16-положительный рак
T0	первичная опухоль не может быть оценена (так в КР)
T1	опухоль до 2 см
T2	опухоль от 2 до 4 см
T3	опухоль более 4 см или с распространением на язычную поверхность надгортанника
T4	гортань, поверхностные мышцы языка, медиальная крыловидная мышца, твёрдое нёбо, нижняя челюсть или подчелюстное пространство

Символ N, p16-положительный рак

1. **cN1** — один или несколько узлов на стороне поражения менее 6 см
2. **cN2** — узлы с обеих сторон или с противоположной стороны до 6 см
3. **cN3** — узлы более 6 см
4. **pN1** — метастазы в 1–4 лимфоузлах
5. **pN2** — метастазы в 5 лимфоузлах и более

Сведения об ENE+ указывают отдельно: от них зависят параметры химиолучевого лечения.

Группировка по стадиям, p16-отрицательный рак

1. 0: Tis N0 M0;
2. I: T1 N0 M0;
3. II: T2 N0 M0;
4. III: T3 N0 M0, T1–3 N1 M0;
5. IVA: T4a N0–2 M0, T1–3 N2 M0;
6. IVB: любая T N3 M0, T4b любая N M0;
7. IVC: любая T, любая N, M1.

Группировка по стадиям, p16-положительный рак

1. I: T0–2 N0–1 M0 (кроме T0 N0);
2. II: T0–2 N2 M0, T3 N0–2 M0;
3. III: T0–3 N3 M0, T4 N0–3 M0;
4. IV: любая T, любая N, M1.

Злокачественные эпителиальные опухоли по МКБ-О (4-е издание)

1. 8070/3 плоскоклеточный рак;
2. 8051/3 бородавчатый рак;
3. 8083/3 базалоидный плоскоклеточный рак;
4. 8052/3 папиллярный плоскоклеточный рак;
5. 8074/3 веретеноклеточный плоскоклеточный рак;
6. 8075/3 аденоидный плоскоклеточный рак;
7. 8560/3 железисто-плоскоклеточный рак;
8. 8082/3 лимфоэпителиальный рак.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: новообразование, не поддающееся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**;
2. физикального обследования: осмотр, пальпация образования, прилежащих тканей и регионарных лимфоузлов;
3. цитологического исследования материала первичной опухоли и лимфоузлов (увеличенных или подозрительных);
4. патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала;
5. инструментального обследования: УЗИ шеи, фиброларингоскопия, эзофагогастроскопия, КТ или МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием, ПЭТ-КТ по показаниям.

3.2 Жалобы и анамнез

Жалобы и анамнез собирают у всех пациентов: они определяют выбор тактики лечения.

Факторы риска

1. курение и крепкие спиртные напитки;
2. производственные вредности;
3. хроническая инфекция: фарингит, тонзиллит, частые ангины, ВПЧ.

Стаж курения оценивают в пачка-годах.

3.3 Осмотр и пальпация

Обследование всех пациентов включает осмотр, в том числе непрямую фарингоскопию, бимануальную пальпацию очага и регионарных лимфоузлов, оценку нутритивного статуса и состояния зубов (врачом-стоматологом).

3.4 Исследование на ВПЧ и экспрессию p16

Биопсийный (операционный) материал всех пациентов исследуют на ВПЧ высокого канцерогенного риска (16-го и 18-го типов) методами ПЦР, ИГХ и (или) гибридизации in situ.

Экспрессия p16 в клетках опухоли (ИГХ) является суррогатным маркером ВПЧ-ассоциации; она предусмотрена классификацией для определения стадии и обязательна к исследованию.

Чувствительность ИГХ и ПЦР высокая, наибольшей специфичностью обладает гибридизация in situ: для ИГХ чувствительность 94–97%, специфичность 83–84%; для гибридизации in situ (ВПЧ 16) 85–88% и 88–95%. Часть p16-положительных опухолей не содержит ДНК ВПЧ, поэтому методы можно сочетать.

3.5 Патолого-анатомическое исследование

В заключении отражают

1. размер опухоли и глубину инвазии;
2. гистологическое строение и степень дифференцировки;
3. лимфоваскулярную и периневральную инвазию (отрицательный результат тоже указывают);
4. pT;
5. pN с числом исследованных и поражённых лимфоузлов и признаками экстранодального распространения;
6. состояние краёв резекции (в том числе отрицательный или близкий край);
7. статус ВПЧ 16-го и 18-го типов.

3.6 Фиброларингоскопия и эзофагоскопия с биопсией

Всем пациентам с подозрением на рак ротоглотки выполняют фиброларингоскопию и эзофагоскопию с биопсией с поверхности эрозий и изъязвлений и (или) взятием материала для цитологического исследования, чтобы верифицировать тип опухоли и исключить вторые опухоли.

3.7 УЗИ лимфоузлов шеи с пункцией

Всем пациентам выполняют УЗИ лимфоузлов шеи с обеих сторон с пункцией подозрительных узлов под контролем УЗИ, чтобы уточнить распространённость и спланировать лечение.

Регионарные метастазы выявляют в 80% случаев, нередко как первое проявление заболевания; подозрительными считают узлы с изменённой по данным лучевой диагностики структурой.

3.8 МРТ или КТ лицевого отдела черепа и шеи

МРТ с внутривенным контрастированием и (или) КТ с болюсным контрастированием от основания черепа до верхней апертуры грудной клетки выполняют всем пациентам с раком ротоглотки и при подозрении на него, чтобы оценить распространённость опухоли.

При симптомах вовлечения черепных нервов предпочтительна МРТ (периневральная инвазия), КТ информативнее для оценки деструкции кортикального слоя кости.

3.9 КТ органов грудной полости

КТ органов грудной полости выполняют всем пациентам для стадирования; если КТ невозможна, выполняют прицельную рентгенографию органов грудной клетки.

3.10 ПЭТ-КТ

Для поиска отдалённых метастазов **при стадии III и выше** (местнораспространённый рак, поражение регионарных лимфоузлов) выполняют ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозой или КТ органов грудной и брюшной полостей с контрастированием. Если они невозможны, выполняют прицельную рентгенографию органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости.

3.11 МРТ головного мозга

При стадии III и выше и клиническом подозрении на метастазы в головной мозг выполняют МРТ головного мозга с контрастированием; если она невозможна, выполняют КТ с внутривенным контрастированием.

3.12 Визуализация для планирования лучевой терапии

Для планирования лучевой терапии используют МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием; если она невозможна, выполняют КТ с болюсным контрастированием или ПЭТ-КТ.

3.13 Оценка эффекта лучевой и химиолучевой терапии

После окончания ЛТ или ХЛТ

1. МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием **через 2–3 месяца**: оценка первичной опухоли и зон регионарного метастазирования;
2. ПЭТ-КТ **не ранее чем через 3 месяца**: решение вопроса об отказе от лимфаденэктомии;
3. пункция подозрительных лимфоузлов под контролем УЗИ **через 2–3 месяца**: подтверждение полной резорбции метастазов перед отказом от лимфаденэктомии.

3.14 Определение экспрессии PD-L1

При нерезектабельном раке и планировании паллиативного лечения определяют уровень экспрессии PD-L1 в опухоли.

---

4. Лечение

4.1 Общие принципы

Специальное противоопухолевое лечение планируют с учётом опыта и оснащённости клиники и предпочтений пациента: важна и эффективность, и качество жизни.

1. **ранние стадии (T1–2 N0 M0)** — предпочтителен один метод, ЛТ или операция; адъювантная ЛТ или ХЛТ и спасительная операция нежелательны из-за суммации побочных эффектов
2. **распространённый рак** — приоритетом является увеличение выживаемости за счёт самостоятельного или комбинированного лечения
3. **рецидив** — лечение направлено на выживаемость и качество жизни с учётом прежнего лечения, возраста и соматического состояния

4.2 Лечение p16-отрицательного рака

Варианты лечения p16-отрицательного рака ротоглотки (M0)

Стадия	Варианты лечения
T1–2 N0	самостоятельная ЛТ (при выборе консервативного лечения) либо операция (см. ниже)
T1–2 N1	одновременная ХЛТ (при выборе консервативного лечения) либо операция (см. ниже)
T1–2 N0–1, хирургическое лечение	удаление первичной опухоли, предпочтительно трансоральным доступом, с ипсилатеральной (латерализованная опухоль) или двусторонней (центральная локализация или переход за среднюю линию) шейной лимфодиссекцией
T3, T4a N0–1	одновременная ХЛТ
T3, T4a N0–1, другой вариант	индукционная ХТ с последующей ЛТ или ХЛТ
T3, T4 N0–1 при противопоказаниях к ЛТ/ХЛТ или отказе от них	операция с одно- или двусторонней шейной лимфодиссекцией; при отсутствии неблагоприятных факторов затем адъювантная ЛТ
T1–4a N2–3	одновременная ХЛТ
T1–4a N2–3, другой вариант	индукционная ХТ с последующей ЛТ или ХЛТ

Стадия	Варианты лечения
T3, T4 N2–3 при противопоказаниях к ЛТ/ХЛТ или отказе от них	операция с одно- или двусторонней шейной лимфодиссекцией; при отсутствии неблагоприятных факторов затем адъювантная ЛТ

При остаточной опухоли и (или) метастатических лимфоузлах после консервативного лечения показано хирургическое лечение, а при полной регрессии метастатических узлов проводят динамическое наблюдение.

Неблагоприятные гистологические факторы после операции (p16-отрицательный рак)

1. близкий край резекции (менее 5 мм);
2. периневральная, периваскулярная, лимфатическая инвазия;
3. pT3 или pT4;
4. pN2 или pN3;
5. метастаз в IV или V группе лимфоузлов шеи.

Тактика после операции

1. **один или несколько факторов** — адъювантная ЛТ либо одновременная ХЛТ; ХЛТ обсуждают индивидуально при двух факторах и более с учётом возраста и соматического состояния
2. **экстракапсулярное распространение метастаза** — адъювантная одновременная ХЛТ
3. **положительные края резекции** — повторная операция, если возможно, или одновременная ХЛТ

4.3 Лечение p16-положительного рака

Варианты лечения p16-положительного рака ротоглотки

Стадия	Варианты лечения
T1–2 N0	самостоятельная ЛТ (при выборе консервативного лечения) либо удаление первичной опухоли (предпочтительно трансоральное) с ипси- или двусторонней селективной шейной лимфодиссекцией или без неё
T1–2 N0, хирургическое лечение	удаление первичной опухоли ± селективная шейная лимфодиссекция; для сохранения качества жизни предпочтительно трансоральное вмешательство
T0–2 N1 (один ипсилатеральный узел до 3 см)	ХЛТ либо самостоятельная ЛТ для снижения токсичности (обсуждается при IMRT/VMAT с учётом опыта клиники)
T1–2 N0–1 (один узел до 3 см), хирургическое лечение	удаление первичной опухоли ± ипси- или двусторонняя шейная лимфодиссекция
T2 N1 (узел более 3 см или 2 и более узла до 6 см с одной стороны), T0–2 N2, T3 N0–2	одновременная ХЛТ
те же стадии, другой вариант консервативного лечения	индукционная ХТ с последующей ЛТ или ХЛТ
те же стадии, хирургическое лечение	удаление первичной опухоли с ипсилатеральной (cN0–3 с одной стороны) или двусторонней (cN2–3 с обеих сторон) шейной лимфодиссекцией
T0–3 N3, T4 N0–3	одновременная ХЛТ

Стадия	Варианты лечения
T0–3 N3, T4 N0–3, другой вариант консервативного лечения	индукционная ХТ с последующей ЛТ или ХЛТ
T0–3 N3, T4 N0–3, хирургическое лечение	удаление первичной опухоли с ипсилатеральной (cN0–3 с одной стороны) или двусторонней (cN2–3 с обеих сторон) шейной лимфодиссекцией

Неблагоприятные гистологические факторы после операции (p16-положительный рак)

1. близкий край резекции;
2. перineвральная, периваскулярная, лимфатическая инвазия;
3. pT3 или pT4;
4. один положительный узел более 3 см или несколько положительных узлов;
5. поражение лимфоузлов IV или V уровня.

Тактика после операции

1. **один или несколько факторов** — адъювантная ЛТ либо одновременная ХЛТ; ХЛТ обсуждают индивидуально при двух факторах и более
2. **экстракапсулярное распространение ± положительные края** — адъювантная одновременная ХЛТ
3. **положительный край резекции** — повторная операция, если возможно, или одновременная ХЛТ

4.4 Рецидив и остаточная опухоль

Без предшествующей лучевой терапии

1. **резектабельный процесс** — хирургическое вмешательство; после него при неблагоприятных факторах адъювантная ЛТ или ХЛТ, при экстракапсулярном распространении или положительных краях ХЛТ
2. **резектабельный процесс, отказ от операции** — одновременная ХЛТ
3. **нерезектабельный процесс** — ХТ с последующим обсуждением ЛТ или ХЛТ

После лучевой терапии

1. **резектабельная опухоль** — хирургическое вмешательство
2. **нерезектабельная опухоль** — индивидуальный план: лекарственная терапия, повторная ЛТ или одновременная ХЛТ, симптоматическое лечение

Повторную лучевую терапию обсуждают при ECOG 0–1 и **не ранее 6 месяцев** (предпочтительно **не ранее 2 лет**) после предшествующего облучения.

Рецидив или остаточная опухоль с отдалёнными метастазами: выбор по общему состоянию

1. **ECOG 0–1** — полихимиотерапия или монотерапия
2. **ECOG 2** — монохимиотерапия или симптоматическое лечение
3. **ECOG 3** — симптоматическое лечение

4.5 Хирургическое лечение

До лечения пациента оценивает хирург, специализирующийся на опухолях головы и шеи: адекватность биопсии, стадирования и визуализации, исключение синхронной опухоли, функциональный статус, план наблюдения (зубы, питание, реабилитация). Объём операции не уменьшают из-за регрессии опухоли до лечения, кроме случаев прогрессирования.

Хирургическое лечение не рекомендуется

1. стадия T4b;
2. непосредственное распространение опухоли из регионарных лимфоузлов на кожу;
3. прямое распространение на структуры средостения, предпозвоночную фасцию или шейные позвонки.

Причины: нерезектабельность, интра- и послеоперационные риски, низкая вероятность радикальной операции.

Первичный очаг удаляют единым блоком: это позволяет оценить края резекции и снижает риск местного рецидива. Предпочтительны трансоральные резекции CO2-лазером под оптическим увеличением или роботассистированные.

Если опухоль прилежит к двигательному или чувствительному нерву, возможна периневральная инвазия: нерв выделяют в проксимальном и дистальном направлениях и резецируют до чистого края, проверяя края нерва срочным исследованием замороженных срезов.

Цель операции: статус R0.

1. **адекватное удаление** — расстояние от края резекции до видимой опухоли **не менее 1,5 см** или отрицательный край замороженного среза
2. **чистый край** — от инвазивного края опухоли до края резекции **не менее 5 мм**
3. **близкий край** — **менее 5 мм**

Описание края резекции вносят в протокол операции; препарат маркируют для патологоанатома, шейную диссекцию ориентируют по уровням. Дефекты по возможности ушивают первично, не жертвуя широкими краями; при необходимости используют местные, регионарные или свободные лоскуты с реконструкцией нижней челюсти или без неё.

При хирургическом лечении выполняют селективную лимфодиссекцию II–IV уровней.

Профилактическая лимфодиссекция II–IV уровней обязательна

1. при распространённости первичной опухоли T3–4;
2. при опухоли миндалины и миндаликовой ямки начиная с T1–2: риск поражения лимфоузлов достигает 50%.

Удаление лимфоузлов II–V уровней — при одном из факторов

1. пальпируемый метастаз в IV или V уровне;
2. регионарный метастаз более 6 см;
3. крупные множественные метастазы (более 3 см);
4. выраженное экстракапсулярное распространение (кивательная мышца, внутренняя яремная вена, общая сонная артерия);
5. рецидив.

4.6 Лучевая терапия

До лечения пациента оценивает радиотерапевт, предпочтительно специализирующийся на опухолях головы и шеи: верификация, стадирование, синхронная опухоль, функциональный статус, план санации полости рта, питания, обезболивания и ранозаживления.

Объём облучения до радикальных доз не меняют из-за ответа на индукционную ПХТ, кроме прогрессирования; при быстром уменьшении опухоли или значительной потере массы тела план пересматривают.

ЛТ проводят в специализированных учреждениях.

Методы облучения

1. предпочтительны высокопрецизионные IMRT и VMAT;
2. при значительных ограничениях дозы на нормальные ткани рассматривают протонную терапию;
3. допустима 3D-конформная ЛТ.

Самостоятельная лучевая терапия

1. **первичный очаг и клинически определяемые метастазы** — 66–70 Гр (2,0–2,2 Гр за фракцию) **за 6–7 недель**, 5 дней в неделю
2. **локорегионарная область, включая лимфоузлы** — 44–50 Гр (2,0 Гр за фракцию) или 54–63 Гр (1,6–1,8 Гр за фракцию)

В специализированных центрах допустима ускоренная схема до 66–70 Гр (2,0 Гр, 6 фракций в неделю). При 3D-конформной ЛТ проводят традиционное фракционирование: 2 Гр до 50 Гр на локорегионарную область и до 70 Гр на первичный очаг и метастазы. При T1–2 N0 возможна брахитерапия по индивидуальному плану.

Одновременная химиолучевая терапия

1. **первичный очаг и клинически определяемые метастазы** — 70 Гр (2,0 Гр за фракцию) **за 6–7 недель**
2. **локорегионарная область** — 44–50 Гр (2,0 Гр за фракцию) или 54–63 Гр (1,6–1,8 Гр за фракцию)

Стандарт: цисплатин 100 мг/м² на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни ЛТ (суммарно 300 мг/м²).

Возможна ЛТ с #карбоплатином 70 мг/м² и #фторурацилом 600 мг/м² в 1–4-й дни каждые 3 недели (схема высокотоксична).

После индукционной ПХТ альтернативой цисплатину служат цетуксимаб (400 мг/м² за неделю до ЛТ, затем 250 мг/м² еженедельно) или карбоплатин.

Цетуксимаб вместо препаратов платины — при высоком риске их побочных эффектов

1. СКФ **менее 50–60 мл/мин**;
2. возраст **старше 65 лет**;
3. выраженная почечная, сердечно-сосудистая, неврологическая, печёночная патология;
4. ослабленное состояние (ECOG более 1).

Польза нетрадиционного фракционирования при одновременной ХЛТ не подтверждена.

Послеоперационная лучевая терапия

1. **ложе опухоли и регионарных метастазов** — 60–66 Гр (2,0 Гр за фракцию) **за 6–6,5 недели**
2. **локорегионарная область, включая неизменённые лимфоузлы** — 44–50 Гр (2,0 Гр) или 54–63 Гр (1,6–1,8 Гр)

Интервал после операции **не более 6 недель** и не должен превышать 3 месяцев. 66 Гр подводят на область высокого риска: положительный край резекции или экстракапсулярное распространение.

Послеоперационную одновременную ХЛТ проводят в тех же дозах ЛТ с препаратами платины, предпочтительно цисплатином 100 мг/м² каждые 3 недели. При сопутствующей патологии, препятствующей платине (хроническая почечная недостаточность, выраженная кардиопатология), платину заменяют цетуксимабом.

Паллиативная ЛТ облегчает или предупреждает локорегионарные симптомы, когда радикальное лечение невозможно; схема индивидуальна, в том числе 50 Гр (2,5 Гр за фракцию) или 30 Гр (3 Гр за фракцию).

4.7 Лекарственная терапия

Индукционная химиотерапия (TPF)

1. доцетаксел: 75 мг/м² в 1-й день;
2. цисплатин: 75 мг/м² в 1-й день;
3. #фторурацил: 1000 мг/м²/сут в 1–4-й дни;
4. курс: всего 2–3 курса с интервалом 3 недели.

Альтернативный режим индукционной ХТ

1. #паклитаксел: 175 мг/м² в 1-й день;
2. цисплатин: 100 мг/м² во 2-й день;
3. #фторурацил: 500 мг/м² длительной инфузией во 2–6-й дни;
4. курс: всего 3 курса с интервалом 3 недели.

Конкурентная ХЛТ после индукции: цисплатин 100 мг/м² 1 раз в 3 недели. С учётом высокой токсичности возможно еженедельное введение карбоплатина (AUC 1,5) или цетуксимаба (400 мг/м² за неделю до ЛТ, затем 250 мг/м² еженедельно); при сопутствующей патологии, препятствующей платине, её заменяют цетуксимабом.

При неоперабельном рецидиве или остаточной опухоли после ЛТ, а также при отдалённых метастазах проводят моно- или полихимиотерапию; режимы приведены в таблице ниже.

Режимы лекарственной терапии плоскоклеточного рака головы и шеи

Режим	Схема проведения
PF + цетуксимаб	цисплатин 75–100 мг/м² в/в в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м²/сут в/в 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза), далее 250 мг/м² еженедельно; после 6 циклов при отсутствии прогрессирования — поддерживающая терапия #цетуксимабом 250 мг/м² еженедельно
DC + цетуксимаб	#доцетаксел 75 мг/м² + цисплатин 75 мг/м² в/в в 1-й день каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза), далее 250 мг/м² еженедельно; после 4 циклов — поддерживающая терапия #цетуксимабом 500 мг/м² 1 раз в 2 недели
Цисплатин + цетуксимаб	цисплатин 75–100 мг/м² 1 раз в 3 недели (не более 6–8 введений) + цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день, далее 250 мг/м² еженедельно до прогрессирования или непереносимой токсичности
Паклитаксел + карбоплатин + цетуксимаб	1. #паклитаксел 100 мг/м² + карбоплатин AUC 2,5 в 1-й и 8-й дни + цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день 1-го цикла, далее 250 мг/м² еженедельно; цикл 21 день; после 6 циклов — поддерживающая терапия #цетуксимабом 250 мг/м² еженедельно; 2. при ECOG 2: #паклитаксел 80 мг/м² + карбоплатин AUC 2,0 еженедельно + цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день 1-го цикла, далее 250 мг/м² еженедельно, затем поддерживающая терапия #цетуксимабом 250 мг/м²; число введений индивидуально.
PF	1. цисплатин 75–100 мг/м² в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели; 2. карбоплатин AUC 5 в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни каждые 3 недели; 3. 6 циклов, при отсутствии токсичности и нарастающем эффекте — до 8.
Паклитаксел + карбоплатин	1. #паклитаксел 175 мг/м² + карбоплатин AUC 5–6 в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов (до 8); 2. #паклитаксел 60–80 мг/м² + карбоплатин AUC 2 еженедельно до прогрессирования или неприемлемой токсичности, не более 18 недель.

Режим	Схема проведения
DC	#доцетаксел 75 мг/м² + цисплатин 75 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов (до 8)
Ниволумаб	3 мг/кг 1 раз в 2 недели, или 240 мг 1 раз в 2 недели, или 480 мг 1 раз в 4 недели до прогрессирования или неприемлемой токсичности, не более 2 лет
Пембролизумаб	#пембролизумаб 200 мг 1 раз в 3 недели или 400 мг 1 раз в 6 недель до прогрессирования или неприемлемой токсичности, не более 2 лет
PF + пембролизумаб	#пембролизумаб 200 мг + карбоплатин AUC 5 или цисплатин 100 мг/м² + #фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни 1 раз в 3 недели (6 циклов), далее #пембролизумаб 200 мг 1 раз в 3 недели или 400 мг 1 раз в 6 недель, всего до 35 введений
Монотерапия при ECOG более 2 (по таблице КР)	1. цисплатин 60–70 мг/м² 1 раз в 3 недели (длительность более 6–8 введений сомнительна); 2. карбоплатин AUC 5–6 1 раз в 3 недели или AUC 2 еженедельно; 3. #паклитаксел 175 мг/м² 1 раз в 3 недели или 80 мг/м² еженедельно; 4. #доцетаксел 70–75 мг/м² 1 раз в 3 недели; 5. #капецитабин 2000 мг/м² внутрь в 2 приёма в 1–14-й дни, перерыв 1 неделя, или 2000 мг/сут ежедневно в метрономном режиме; 6. #метотрексат 40 мг/м² еженедельно; 7. #цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день 1-го курса, далее 250 мг/м² еженедельно.

Примечания к таблице

1. паклитаксел + карбоплатин + цетуксимаб еженедельно: для пациентов с ECOG 2;
2. PF, паклитаксел + карбоплатин и DC — неоптимальные режимы: только при абсолютных противопоказаниях к анти-EGFR моноклональным антителам;
3. ниволумаб — во 2-й и последующих линиях при платинорезистентных опухолях, независимо от экспрессии PD-L1;
4. пембролизумаб — в 1-й линии при PD-L1 CPS более 20; при прогрессировании на фоне или после платиносодержащей ХТ — при TPS ≥ 50%;
5. PF + пембролизумаб — в 1-й линии при экспрессии PD-L1 ≥ 1%;
6. метотрексат: при плохой переносимости дозу снижают.

4.8 Обезболивание и угроза кровотечения

Обезболивание проводят по клиническим рекомендациям «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи».

При местнораспространённом раке с угрозой кровотечения или состоявшимся кровотечением из опухоли и (или) метастатических узлов выполняют ангиографию наружной сонной артерии и при отсутствии противопоказаний суперселективную эмболизацию сосудов опухоли.

Риск кровотечения констатируют при

1. изъязвлённой местнораспространённой опухоли с вовлечением соседних структур;
2. полости в области опухоли или рецидива;
3. близости опухоли к ветвям сонной артерии;
4. незаживающей ране;
5. состоявшемся кровотечении из опухоли.

4.9 Медицинская реабилитация

До начала лечения проводят программы профилактической гимнастики и обучение тактике глотания: они уменьшают нарушения глотания при противоопухолевой терапии.

Нутритивно-метаболическая реабилитация повышает выживаемость, снижает частоту осложнений и улучшает переносимость лечения.

Нутритивная поддержка перед операцией или ЛТ — при одном из факторов

1. непреднамеренная потеря **5% массы тела и более за 6 месяцев**;
2. индекс массы тела **менее 20 кг/м²**;
3. белок менее 60 г/л или альбумин менее 30 г/л;
4. ухудшение приёма пищи за последнюю неделю.

При химиотерапии

1. индекс массы тела менее 20 кг/м^2;
2. потеря более 5% массы тела за 6 месяцев;
3. белок менее 60 г/л или альбумин менее 30 г/л;
4. невозможность адекватного питания через рот;
5. энтеропатия средней и тяжёлой степени.

При лечении с высоким риском нарушения питания (ХЛТ местнораспространённого рака глотки) рассматривают профилактическую нутритивную поддержку.

1. **энтеральное питание** — при питании через рот менее 60% потребностей **в течение 10 дней** или потере более 10% исходной массы тела
2. **предпочтительный способ** — сиппинг высокобелковыми смесями
3. **при невозможности питания через рот** — назогастральный зонд (при сроке **до 3–4 недель**) или гастростомия; при необходимости парентеральное питание
4. **потребности** — белок не менее 1,2 г/кг/сут и до 2 г/кг/сут, энергия 25–30 ккал/кг/сут

При ЛТ и ХЛТ регулярно оценивают нутритивный статус по шкалам MUST и NRS 2002 и корригируют его специализированным питанием.

Всем пациентам перед ЛТ или ХЛТ показаны консультация и обследование у стоматолога с сопровождением на всех этапах лечения; при болевом синдроме во время и после ЛТ показана консультация врача по паллиативной медицинской помощи (альголога).

При химио- и химиолучевой терапии рекомендуется раннее начало физических нагрузок (ЛФК с аэробной нагрузкой и упражнениями на сопротивление): они уменьшают слабость и утомляемость, предупреждают саркопению. Для коррекции полинейропатии применяют физическую реабилитацию, иглорефлексотерапию и низкочастотную магнитотерапию (при ХТ препаратами платины).

Низкоинтенсивное лазерное излучение на область дёсен и слизистую оболочку полости рта применяют для профилактики и лечения мукозита полости рта и глотки на фоне ХЛТ; для профилактики тяжёлого мукозита используют медицинский массаж лица.

При лучевом мукозите применяют ранозаживляющие средства, орошение изотоническим раствором, местные анестетики и системные анальгетики по шкале ВОЗ, чаще опиоиды, в том числе трансдермальные. При лучевом дерматите используют ранозаживляющие и солнцезащитные средства. В ранние сроки после облучения избегают инвазивных процедур и биопсии без крайней необходимости.

Удаление зубов в зоне облучения часто приводит к лучевому остеомиелиту, поэтому по возможности ограничиваются консервативным лечением зубов, а удаляют их только при необходимости и на фоне антибиотикотерапии.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика и ранняя диагностика

На что обращают внимание

1. первичные жалобы: самостоятельно обнаруженные язвы, узлы, асимметрия ротоглотки, боль и ощущение комка в горле, онемение, дискомфорт при глотании, лихорадка без видимой причины, образования на шее, неприятный запах изо рта, изменение голоса, трудности с жеванием, ограничение движений языка, тризм;
2. канцерогенные факторы: курение (в том числе пассивное), алкоголь, асбест, древесная пыль, продукты нефтепереработки, ионизирующее облучение, ВПЧ;
3. предопухолевые заболевания: хронические воспалительные заболевания, лейкоплакия слизистой оболочки ротоглотки, папилломы.

5.2 Диспансерное наблюдение

Частота обследования после лечения

1. 1-й год: **каждые 1–3 месяца**;
2. 2-й год: **каждые 2–6 месяцев**;
3. 3–5-й годы: **1 раз в 4–8 месяцев**;
4. после 5 лет: ежегодно или при появлении жалоб.

При высоком риске рецидива интервалы сокращают.

Объём обследования

1. анамнез и физикальное обследование, фиброларингоскопия;
2. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон, органов брюшной полости и малого таза;
3. МРТ или КТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием;
4. прицельная рентгенография органов грудной клетки каждые 12 месяцев;
5. КТ или МРТ органов грудной и брюшной полостей, ПЭТ-КТ — по показаниям;
6. ТТГ каждые 6–12 месяцев, если облучалась шея.

Задача наблюдения: раннее выявление прогрессирования, рецидива и метахронных опухолей головы и шеи.

Контроль после лечения по разделу 2.4.3

1. осмотр зоны интереса, при неинформативности фиброларингоскопия, и УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон: **каждые 1–3 месяца** в 1-й год, 2–6 месяцев во 2-й, 4–8 месяцев на 3–5-м году, далее ежегодно;
2. КТ или МРТ лицевого отдела черепа и шеи: по клиническим показаниям или если осмотр зоны невозможен;
3. КТ органов грудной полости: при I–II стадии **каждые 12 месяцев**; при III–IV стадии и N+ **каждые 6 месяцев до 5 лет**, далее ежегодно (если КТ невозможна, рентгенография).

При симптомах рецидива или установленном рецидиве выполняют ПЭТ-КТ или КТ органов грудной и брюшной полостей с контрастированием, чтобы оценить распространённость и выбрать тактику.

5.3 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой врач направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи или первичный онкологический кабинет; консультация проводится **не позднее 5 рабочих дней** с даты направления.

Патологоанатомическая верификация занимает **не более 15 рабочих дней** с поступления материала.

Тактику лечения определяет онкологический консилиум: онкологи, радиотерапевт, при необходимости другие специалисты.

1. **экстренная или неотложная госпитализация** — осложнения заболевания или его лечения, требующие специализированной помощи
2. **плановая** — сложные интервенционные диагностические вмешательства; специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в стационаре

Показания к выписке

1. завершение курса или этапа лечения без осложнений, требующих стационарной помощи;
2. отказ пациента от продолжения стационарного лечения при отсутствии таких осложнений;
3. несоблюдение режима, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих;
4. необходимость перевода в другую профильную медицинскую организацию.

Факторы прогноза

1. размеры и распространённость первичной опухоли, глубина инвазии;
2. степень дифференцировки;
3. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
4. статус регионарных лимфоузлов (pN): метастазы в лимфоузлах шеи вдвое снижают выживаемость;
5. экстранодальное распространение; статус краёв резекции (R0–1);
6. ВПЧ-статус опухоли.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак ротоглотки»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 14.08.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	4_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 монотерапия предназначена «для пациентов в общем состоянии по ECOG> 2 баллов», тогда как в разделе 3.1 монохимиотерапия рекомендована при ECOG 2, а при ECOG 3 — только симптоматическое лечение. Вероятно, имеется в виду ECOG 2.

Клинические рекомендации

Рак щитовидной железы у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C73** — Злокачественное новообразование щитовидной железы
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.01.2025, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/74_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- У детей рак щитовидной железы встречается реже, чем у взрослых, но протекает агрессивнее, особенно до полового созревания. В среднем 80% случаев составляет папиллярный рак, для которого характерны метастазы в лимфатические узлы шеи (80–90%).
- Ларингоскопия выполняется всем пациентам перед операцией: она подтверждает явные или исключает скрытые парезы и параличи голосовых складок, оценивает подвижность надгортанника.
- Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТПАБ) с цитологическим исследованием показана всем пациентам с подозрением на рак вне зависимости от размера узла; заключение оформляется по системе Bethesda.
- Минимальный объём операции — гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка; при папиллярном раке у детей до пубертата выполняется тиреоидэктомия, кроме стадии T1aN0M0.
- Паралич возвратного гортанного нерва после операции у опытного хирурга развивается менее чем в 2% случаев, преходящая дисфункция голоса — значительно чаще. После операции на ларингоскопию направляют всех пациентов, даже при неизменённом голосе.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Рак щитовидной железы — злокачественная опухоль, развивающаяся из элементов железистого эпителия щитовидной железы.

2.2 Этиология и эпидемиология

Гистологические формы у детей

1. **папиллярный рак** — 70–99%, в среднем 80% случаев; регионарные метастазы в лимфатические узлы шеи — 80–90%, внутрижелезистая диссеминация — 30–81%, метастазы иногда являются единственным проявлением заболевания
2. **фолликулярный рак** — 5–12% случаев; у детей, в отличие от взрослых, течение доброкачественное и медленное

Отдалённые метастазы развиваются у 30–35% детей и подростков, как правило в лёгких. Чем меньше возраст ребёнка, тем агрессивнее течение, чаще экстратиреоидное распространение, регионарные и лёгочные метастазы.

Медуллярный рак составляет 2–25% (чаще 2–5%) случаев, в 70% это семейный вариант. Семейные формы встречаются изолированно или в составе синдромов множественных эндокринных неоплазий (МЭН), причиной которых является наследуемая мутация в протоонкогене RET.

1. **МЭН 2А (синдром Сиппла)** — медуллярный рак, феохромоцитома (10–60%), патология паращитовидных желёз (20–23%), кожный лихеноидный амилоидоз (менее 5%)
2. **МЭН 2Б (синдром Горлина)** — медуллярный рак, феохромоцитома (50–60%), множественные невриномы слизистой оболочки полости рта, губ, век, марфаноидное телосложение

Недифференцированный рак у детей описан в виде единичных случаев.

Факторы риска узловых образований щитовидной железы у детей

1. дефицит йода;
2. предшествующее облучение, особенно малыми дозами;
3. заболевания щитовидной железы у родственников;
4. генетический синдром у пациента.

К группе высокого риска относятся дети, получавшие лучевую терапию на область шеи по поводу злокачественной опухоли, особенно **в возрасте до 1 года**:

1. лимфомы Ходжкина;
2. опухоли ЦНС;
3. лейкоза;
4. нейробластомы;
5. опухолей мягких тканей лица и шеи.

Рак щитовидной железы составляет 1–1,5% злокачественных опухолей в возрасте до 18 лет и 8–22% злокачественных солидных опухолей головы и шеи. Основной возраст на момент заболевания — 8–14 лет, 61% детей заболевают в 11–14 лет; девочки болеют в 2–6 раз чаще мальчиков.

2.3 Классификация

Стадии дифференцированного рака у детей

Стадия	Сочетание T, N, M
I	любое T, любое N, M0
II	любое T, любое N, M1

Метастазы в регионарных лимфатических узлах, выявленные в первые 3 месяца после операции, и отдалённые метастазы, выявленные в первые 6 месяцев, расцениваются как первично диагностированные; выявленные позже — как рецидив.

Стадии медуллярного рака

Стадия	Сочетание T, N, M
I	T1 N0 M0
II	T2–T3 N0 M0
III	T1–T3 N1a M0
IVA	T1–T3 N1b M0
IVB	T4, любое N, M0
IVC	любое T, любое N, M1

Группы риска рецидива и отдалённых метастазов

1. **низкий риск** — опухоль ограничена щитовидной железой (T1–T2), N0 или микрометастазы не более чем в 3 лимфатических узлах VI уровня
2. **средний риск** — T3, поражение лимфатических узлов N1a или не более 3 узлов N1b
3. **высокий риск** — T4, поражение лимфатических узлов N1b, M1 или без отдалённых метастазов

2.4 Клиническая картина

Клиническая картина у детей, как правило, очень скудна: деформация и асимметрия шеи за счёт узла щитовидной железы или увеличенных лимфатических узлов. Увеличение регионарных узлов — второй по частоте симптом; метастазы в регионарных узлах выявляются в 84% наблюдений, в 54% из них — раньше изменений в щитовидной железе.

1. **врастание опухоли в трахею** — затруднение дыхания при длительном течении
2. **прорастание возвратного нерва** — изменения голоса от осиплости до афонии (чрезвычайно редкое проявление)
3. **метастазы в лёгких** — дыхательная недостаточность при диссеминации

У детей и подростков не бывает клинически латентных карцином: даже очень малая опухоль может давать регионарные и отдалённые метастазы. Термин «микрокарцинома щитовидной железы» у детей не применяется.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Окончательный диагноз и распространённость устанавливаются после планового патолого-анатомического исследования операционного материала и сцинтиграфии всего тела.

Дифференциальная диагностика

1. **опухоль щитовидной железы** — аденома, узловой зоб, острые и хронические тиреоидиты, реже туберкулёз, актиномикоз, эхинококкоз
2. **регионарные метастазы** — банальные лимфаденопатии, туберкулёз, срединные и боковые кисты шеи, болезнь Ходжкина

Решающее значение имеет цитологическое исследование пунктата узла.

3.2 Жалобы и анамнез

В начальном периоде жалоб нет. По мере роста узла возникают дискомфорт в области шеи при глотании, изменение тембра голоса, кашель, пальпируемое образование в проекции щитовидной железы, увеличение шейных лимфатических узлов.

Нередко ребёнок длительно, порой два года и более, лечится у педиатра или детского хирурга по поводу предполагаемого шейного лимфаденита, прежде чем устанавливается диагноз рака щитовидной железы с метастазами в шейные узлы.

При подозрении на медуллярный рак дополнительно уточняют

1. медуллярный рак у ближайших родственников;
2. патологию околощитовидных желёз: частые переломы, камни в почках;
3. феохромоцитому: гипертонические кризы и инсульты в молодом возрасте;
4. диарею.

При подозрении на рак показана консультация детского онколога и детского эндокринолога. При сборе анамнеза уточняют случаи рака щитовидной железы и внезапной смерти в семье, время появления деформации шеи и скорость изменений.

3.3 Физикальное обследование

Обследование всех пациентов

1. наружный осмотр, измерение роста, массы тела, оценка физического развития;
2. пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов шеи, брюшной полости, аускультация лёгких;
3. оценка нарушения голосовой функции, затруднения дыхания, глотания, одышки в покое и при нагрузке.

Нарушения голоса, дыхания и глотания могут свидетельствовать о выходе опухоли за пределы щитовидной железы, одышка — и о поражении лёгких.

На начальных стадиях рак представлен одиночным узлом плотно-эластичной консистенции, смещаемым при глотании. По мере выхода за капсулу опухоль становится малоподвижной, не смещается при глотании, спаяна с окружающими мягкими тканями.

3.4 Лабораторные исследования

Обследование при подозрении на рак и перед радиойодтерапией

1. общий (клинический) анализ крови развёрнутый, биохимический анализ крови, общий анализ мочи;
2. тиреотропный гормон (ТТГ), свободный тироксин, тиреоглобулин, кальцитонин при узлах, подлежащих ТАБ;
3. антитела к тиреопероксидазе и тиреоглобулину;
4. тиреоглобулин или кальцитонин в смыве иглы после пункции изменённых лимфатических узлов;
5. маркеры гепатитов B и C, антитела к ВИЧ.

При подозрении на медуллярный рак исследуется базальный и стимулированный кальцитонин крови; стимулированный определяют через 2 и 5 минут после введения #кальция глюконата из расчёта 0,27 мг/кг. Повышенный кальцитонин служит маркером медуллярного рака.

3.5 Ультразвуковое исследование

УЗИ при подозрении на рак и перед радиойодтерапией

1. щитовидная и паращитовидные железы;
2. лимфатические узлы шеи;
3. органы брюшной полости и забрюшинное пространство.

Оцениваются размеры, структура и число узлов, кровоснабжение, кальцинаты, целостность капсулы, связь опухоли с гортанью и трахеей.

Пункционной биопсии подлежат узлы категорий TI-RADS 3–5; узлы TI-RADS 3 — при размере **1 см и более**.

При УЗИ брюшной полости обязательно оцениваются печень, поджелудочная железа, надпочечники (исключение феохромоцитомы), яичники у девочек; при медуллярном раке обязательно УЗИ надпочечников.

3.6 Ларингоскопия

Показания

1. все пациенты с подозрением на рак и с установленным диагнозом — перед операцией;
2. нарушение фонации, затруднение дыхания — ларингоскопия обязательна.

Диагностические признаки

1. явные или скрытые парезы и параличи голосовых складок;
2. ограничение подвижности надгортанника;
3. вовлечение возвратного нерва в опухоль или его повреждение при предыдущих операциях;
4. врастание опухоли в стенку трахеи.

При подозрении на врастание опухоли в трахею или пищевод показаны трахеоскопия и эзофагоскопия.

3.7 Лучевые методы исследования

Показания

1. **КТ органов грудной полости с шагом 1 мм** — все пациенты с подозрением на рак и перед радиойодтерапией — для исключения метастазов в лёгких
2. **КТ и/или МРТ шеи с внутривенным контрастированием** — подозрение на врастание опухоли в трахею, пищевод, загрудинное расположение опухоли, поражение лимфатических узлов верхнего средостения — перед планированием операции

МРТ с контрастированием выявляет образование от 1–2 мм, прорастание в гортань, трахею, пищевод, отношение к магистральным сосудам, метастазы в ретротрахеальных узлах и узлах верхнего средостения.

При неясных данных УЗИ или признаках вовлечения органов брюшной полости и забрюшинного пространства выполняется МРТ с контрастированием.

Сцинтиграфия

1. **щитовидной железы и лимфатических узлов шеи** — подозрение на рак и подготовка к радиойодтерапии; рак, как правило, визуализируется как «холодный» узел
2. **с натрия йодидом [131I] или [123I]** — оценка радикальности операции и подозрение на рецидив
3. **костей всего тела** — медуллярный и анапластический рак

При подозрении на рецидив медуллярного и дифференцированного рака выполняется ПЭТ-КТ всего тела с туморотропными радиофармпрепаратами; основное показание — рост тиреоглобулина или кальцитонина при отсутствии накопления 131I.

При медуллярном раке в сочетании с синдромом МЭН 2Б выполняются эзофагогастроскопия и колоноскопия для исключения неврином слизистой оболочки.

3.8 Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия

ТПАБ узла (узлов) щитовидной железы и увеличенных лимфатических узлов шеи с цитологическим исследованием выполняется при любом подозрении на рак вне зависимости от размера узла; на цитологическом заключении основывается клинический диагноз.

Цитологические категории Bethesda (2023)

Категория Bethesda	Вероятность злокачественности	Рекомендации
I — неинформативный материал	0–33%	повторная ТПАБ под контролем УЗИ
II — доброкачественное образование	0–27%	наблюдение с УЗИ

Категория Bethesda	Вероятность злокачественности	Рекомендации
III — атипия неопределённого значения	11–54%	повторная ТПАБ под контролем УЗИ или диагностическая гемитиреоидэктомия
IV — фолликулярная опухоль	28–100%	гемитиреоидэктомия
V — подозрение на злокачественное новообразование	40–100%	гемитиреоидэктомия или тиреоидэктомия
VI — злокачественное новообразование	86–100%	тиреоидэктомия или гемитиреоидэктомия

При неопределённом цитологическом заключении, не соответствующем клинике, ТАБ повторяют. Показанием к повторному исследованию является изменение структуры узла при динамическом наблюдении, которое проводится **не реже 1 раза в 3 месяца**.

При подозрении на поражение лимфатического узла выполняется его пункция под контролем УЗИ с исследованием тиреоглобулина или кальцитонина в смыве из иглы: это позволяет сделать заключение о метастатическом поражении.

3.9 Иные исследования

При подозрении на наследственную форму и при медуллярном раке показаны консультация генетика и молекулярно-генетическое исследование крови:

1. мутаций в гене RET;
2. мутации BRAF V600;
3. мутаций в гене TP53.

При семейной форме медуллярного рака генетическое исследование проводится и братьям, сёстрам, родителям пациента.

Всем пациентам выполняется патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала щитовидной железы и лимфатических узлов для верификации диагноза.

Если биопсия или операция выполнены в непрофильной организации, целесообразен повторный патолого-анатомический пересмотр материала в профильной медицинской организации.

---

4. Лечение

Методами лечения являются хирургический, лучевой (радиойодтерапия и дистанционная лучевая терапия), лекарственный и их комбинация; цель лечения — полное выздоровление. Основным методом является хирургический.

4.1 Хирургическое лечение

Всем детям с раком щитовидной железы при операции рекомендуется интраоперационный нейромониторинг.

Операция выполняется радикально, но максимально органосохраняюще по отношению к жизненно важным анатомическим структурам, в специализированных стационарах с наибольшим опытом операций у детей.

Перед операцией необходимы

1. согласие родителей (законных представителей) или самого пациента с 15 лет;
2. заключение детского онколога и/или детского эндокринолога о диагнозе или подозрении на рак;
3. отсутствие декомпенсированных хронических заболеваний, тяжёлых органных дисфункций;
4. отсутствие тяжёлой инфекции;
5. отрицательный тест на беременность у девушек старше 12 лет;
6. отсутствие аллергии на препараты для местной анестезии и общего наркоза.

Показания к хирургическому лечению дифференцированного рака

1. категория Bethesda III при узле более 1 см, тенденции к росту, изменённых лимфатических узлах, парезе голосовой складки не травматического и не ятрогенного генеза, принадлежности к группе высокого риска — диагностическая гемитиреоидэктомия; при узле **менее 1 см** — повторная ТПАБ **через 3–6 месяцев**;
2. категории Bethesda IV, V и VI;
3. метастатическое поражение лимфатического узла шеи по данным пункции;
4. отдалённые метастазы рака щитовидной железы.

Объём операции на щитовидной железе

Форма и стадия	Объём операции
любая форма	минимальный объём — гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка; при папиллярном раке у детей до пубертата — тиреоидэктомия, кроме T1aN0M0
папиллярный рак до 1 см, N0 или не более 3 микрометастазов в пре- и паратрахеальных узлах (T1aN0–1aM0)	гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка и центральной лимфодиссекцией
T1bN0–1aM0 при интратиреоидной опухоли с интактной капсулой, благоприятном морфологическом варианте, одностороннем поражении, без изменённых узлов, наследственного анамнеза и облучения	допустима гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка и центральной лимфодиссекцией
T1aN0M0 у детей более 10 лет после радиационного воздействия	гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка
стадия выше T1bN0–1aM0	тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией
папиллярный рак до 1 см при многофокусной опухоли или метастазах, выявленных до операции	тиреоидэктомия

Форма и стадия	Объём операции
папиллярный рак T1a–T4 N1b	экстрафасциальная тиреоидэктомия с удалением лимфатических узлов I–VI уровней с одной или двух сторон
фолликулярный рак T1–T3a N0M0 без признаков инвазии по УЗИ	экстрафасциальная гемитиреоидэктомия с удалением перешейка; при микрометастазах не более чем в 3 узлах — с центральной лимфодиссекцией на стороне поражения
фолликулярный рак N1a–N1b	экстрафасциальная тиреоидэктомия с удалением узлов VI уровня и боковой клетчатки шеи по уровню поражения

При папиллярном раке у детей регионарные метастазы очень часты, поэтому всем пациентам превентивно удаляют центральную (паратрахеальную, претрахеальную и преларингеальную) клетчатку шеи с лимфатическими узлами.

Удаление других групп узлов основывается на предоперационном обследовании и интраоперационной ревизии: от центральной (VI уровень) до боковой лимфодиссекции (II–VI уровни), при необходимости — узлы I и VII уровней.

1. **фолликулярный рак T1–T3N0M0** — возможна гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка и центральной лимфодиссекцией
2. **фолликулярный рак N1** — тиреоидэктомия с центральной и, по уровню поражения, боковой лимфодиссекцией

Лимфатические узлы и клетчатку шеи при фолликулярном раке удаляют только при доказанных метастазах: превентивная центральная лимфодиссекция не проводится из-за очень редкого метастазирования.

При метастазах в боковом коллекторе шеи дополнительно выполняется боковая лимфодиссекция с удалением узлов II–VI уровней на стороне поражения или с двух сторон; при этом необходимо выделить и сохранить добавочный нерв.

Целостность гортанных нервов контролируется нейромонитором в процессе выделения щитовидной железы и иссечения метастазов, их целостность и функциональность фиксируются по окончании операции. Обязательны контроль и сохранение околощитовидных желёз; удалённые околощитовидные железы измельчают и имплантируют в мышцы шеи.

Прорастание опухоли в трахею и пищевод у детей наблюдается редко.

1. **без отдалённых метастазов** — хирургическая резекция с учётом общего состояния: от «окончатой» резекции трахеи до комплексных ларинготрахеальных и эзофагеальных резекций
2. **при отдалённых метастазах** — целесообразнее поверхностное удаление опухоли на гортани и трахее («плоскостная» резекция, сбривание) с учётом последующей радиойодтерапии

При отсутствии дооперационной гистологической верификации хирург изучает макропрепарат (капсула узла, её прорастание, дополнительные очаги), маркирует опухоли. При категориях Bethesda III–V и подозрительных узлах центральной клетчатки выполняется срочное гистологическое исследование: при метастазах и опухоли более 1 см объём расширяется до тиреоидэктомии с центральной лимфодиссекцией.

Повторная операция на шее

1. рак выявлен при плановом гистологическом исследовании после операции по поводу предполагаемого доброкачественного узла, а объём не соответствовал критериям;
2. рецидив в оставшейся ткани щитовидной железы — тиреоидэктомия с удалением узлов VI уровня;
3. рецидив метастазов в лимфатических узлах шеи — удаление поражённых узлов с клетчаткой и оставшейся тканью щитовидной железы.

Повторная операция не выполняется при опухоли **не более 20 мм**, единичном фокусе в капсуле без капсулярной и сосудистой инвазии, без регионарных метастазов или с микрометастазами не более чем в 3 узлах центральной клетчатки, а также при минимально инвазивном фолликулярном раке T1a–T3aN0M0.

После тиреоидэктомии с центральной лимфодиссекцией определяют паратгормон и кальций; при патологических значениях для профилактики гипокальциемических судорог назначается альфакальцидол 25–50 нг/кг/сут внутрь под контролем кальция крови вместе с препаратами кальция.

4.2 Медуллярный рак

Детям и подросткам с медуллярным раком рекомендовано хирургическое лечение.

1. **любой размер опухоли** — только тиреоидэктомия с центральной или боковой лимфодиссекцией (II–VI уровни на стороне поражения или с двух сторон)
2. **семейные формы** — во всех случаях тиреоидэктомия, центральная и боковая лимфодиссекция
3. **аденомы околощитовидных желёз** — удаляются во время операции
4. **сопутствующая феохромоцитома** — сначала удаляют её, затем оперируют щитовидную железу

При спорадическом медуллярном раке объём вмешательства на лимфатическом коллекторе такой же, как при папиллярном. При наследственных формах, особенно при синдроме МЭН, в разделе 3.1 рекомендованы тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией и боковая лимфодиссекция на стороне поражения при подозрении на метастазы.

4.3 Радиойодтерапия

При дифференцированном раке после тиреоидэктомии радиойодтерапия рекомендуется только пациентам высокой и промежуточной групп риска прогрессирования. Рекомендуемый срок — **до 6 месяцев** после операции.

Перед радиойодтерапией

1. ТТГ (рекомендуемый уровень более 30 мкМЕ/мл), свободный Т4, тиреоглобулин, антитела к тиреоглобулину;
2. общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи;
3. УЗИ щитовидной и паращитовидных желёз и лимфатических узлов;
4. первичный осмотр оториноларинголога;
5. КТ органов грудной полости.

Для подготовки отменяют левотироксин натрия **за 2 недели** до процедуры, назначают йод-ограниченную диету до 2 недель, **в течение 2–3 месяцев** избегают КТ с йодсодержащим контрастом.

4.4 Лучевая и лекарственная терапия

Дистанционная лучевая терапия при дифференцированном раке малоэффективна и рекомендована только при врастании опухоли в соседние органы, невозможности радикального удаления или с паллиативной целью при неэффективности ингибиторов протеинкиназ.

При радиойодрефрактерном дифференцированном раке вопрос о таргетной терапии решает онкологический консилиум; обязательным условием её начала является прогрессирование.

Признаки радиойодрефрактерности

1. отсутствие поглощения натрия йодида [131I] во всех очагах;
2. отсутствие накопления хотя бы в одном из очагов;
3. прогрессирование на фоне радиойодтерапии, несмотря на поглощение;
4. достижение максимальной рекомендуемой активности.

При прогрессировании рецидивного неоперабельного или метастатического рака после неэффективной радиойодтерапии предпочтителен #ленватиниб; при прогрессировании на стандартной таргетной терапии — комплексное геномное секвенирование опухоли (мутации RET, слияния NTRK). При неоперабельном медуллярном раке с отдалёнными метастазами с паллиативной целью применяется #вандетаниб.

Цитотоксическая химиотерапия у детей с папиллярным и фолликулярным раком нецелесообразна; её применение ограничено прогрессированием, когда невозможны операция, радиойодтерапия и другие методы.

При местном и регионарном рецидиве лечение основано на сочетании операции и терапии натрия йодидом [131I], если очаги накапливают изотоп; при невозможности полного удаления и незначительном накоплении проводится дистанционная лучевая терапия.

4.5 Осложнения хирургического лечения

После операции всех пациентов, даже при неизменённом голосе, рекомендуется направлять на ларингоскопию.

Паралич возвратного гортанного нерва у опытного хирурга наблюдается редко (менее 2% случаев), у непрофильных хирургов — чаще. Преходящая дисфункция голоса встречается значительно чаще и у большинства пациентов разрешается спонтанно **в течение 1–6 месяцев**.

После тиреоидэктомии с центральной лимфодиссекцией гипокальциемия возникает в трети случаев. Общий и ионизированный кальций определяют **через 8 часов** после операции, затем ежедневно до стабилизации; обязателен контроль магния.

1. **общий кальций** **менее 2,1 ммоль/л** — альфакальцидол 0,5 мкг сразу, при дальнейшем снижении — ещё 0,5 мкг
2. **ионизированный кальций** **менее 0,95 ммоль/л** **или симптомы гипокальциемии** — кальция глюконат 10% 10 мл внутривенно **в течение 10 минут**, затем 1–2 мг/кг/ч **в течение 4–5 часов** через инфузомат; параллельно альфакальцидол 0,5–2 мкг и препараты кальция внутрь

Критический уровень ионизированного кальция — **менее 0,8 ммоль/л**.

Супрессивная терапия левотироксином натрия показана при папиллярном и фолликулярном раке промежуточной и высокой групп риска. В группе минимального риска после пубертата левотироксин натрия не назначается; ТТГ исследуют **через 4–6 недель** после операции и решают вопрос о заместительной терапии.

При постоянном гипопаратиреозе назначается заместительная терапия витамином D и его аналогами с препаратами кальция под тщательным контролем кальция крови.

По разделу 7.1, после операции по поводу дифференцированного рака в объёме меньше тиреоидэктомии всем пациентам назначается левотироксин натрия, кроме периода подготовки к радиойоддиагностике или радиойодтерапии.

4.6 Медицинская реабилитация

На всём протяжении лечения в план реабилитации включаются социально-педагогическая помощь ребёнку и социально-психологическая поддержка семьи.

Задачи реабилитации

1. устранение косметических дефектов после операции;
2. устранение нарушений лимфооттока после обширных лимфодиссекций;
3. восстановление функции голосообразования и физиологического дыхания.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Пациенты, оперированные по поводу рака щитовидной железы, пожизненно наблюдаются детским онкологом (онкологом) и детским эндокринологом (эндокринологом) в специализированном центре или другой медицинской организации.

Периодичность контрольных обследований

1. **первый год** — каждые 3 месяца
2. **в течение пяти лет** — не реже 1 раза в полгода
3. **далее** — не реже 1 раза в год, пожизненно

Объём обследования

1. осмотр детского онколога;
2. УЗИ щитовидной и паращитовидных желёз;
3. КТ органов грудной полости не реже 1 раза в год;
4. ТТГ, тиреоглобулин, антитела к тиреоглобулину;
5. при стойком гипопаратиреозе — паратгормон, общий и ионизированный кальций, фосфор.

При лимфатическом узле более 5 мм в наименьшем диаметре выполняется ТПАБ под контролем УЗИ с цитологическим исследованием.

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на узловое поражение щитовидной железы педиатр или другой специалист направляет ребёнка в эндокринологический или детский онкологический центр.

Операция выполняется в профильных детских онкологических или специализированных эндокринологических учреждениях опытными хирургами мультидисциплинарной команды.

5.3 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. биопсия, хирургическое, лучевое, лекарственное лечение;
2. коррекция осложнений лечения, требующая пребывания в стационаре;
3. манипуляции под общей анестезией.

Критерии выписки

1. окончание этапа терапии при стабильном удовлетворительном соматическом статусе;
2. окончание всего лечения, достижение ремиссии при стабильном удовлетворительном соматическом статусе;
3. инкурабельность с возможностью перевода под наблюдение паллиативной службы или в хоспис.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак щитовидной железы»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	74_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Фолликулярный рак T1–T3N0M0: одна рекомендация раздела 3.1 называет объём «гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка с центральной лимфодиссекцией шеи», а следующая рекомендация и комментарий того же раздела указывают, что превентивная центральная лимфодиссекция при фолликулярном раке не проводится, а узлы удаляют только при доказанных метастазах; в комментарии ниже для этой стадии без метастазов указана гемитиреоидэктомия без лимфодиссекции.
- Наследственный медуллярный рак: раздел 3.1 рекомендует тиреоидэктомию с центральной лимфодиссекцией и боковую лимфодиссекцию только при подозрении на метастазы, раздел 3.3 — боковую лимфодиссекцию II–VI уровней при семейных формах во всех случаях.
- Левотироксин натрия после операции в объёме меньше тиреоидэктомии: раздел 7.1 предписывает его всем пациентам, раздел 7.2 — не назначать в группе минимального риска у пациентов, достигших пубертата.
- Показания к ТПАБ узлов TI-RADS 3 менее 1 см (раздел 2.4): фраза о таких узлах обрывается после перечня обстоятельств (изменённые лимфатические узлы, парез голосовой складки, группа высокого риска), и вывод в тексте не приведён.

Клинические рекомендации

Расщелина верхней губы и нёба

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**Q35** — Расщелина неба [волчья пасть] **Q36** — Расщелина губы [заячья губа] **Q37** — Расщелина неба и губы [волчья пасть с заячьей губой]
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.06.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Общероссийская общественная организация «Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1050_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Расщелина губы и (или) нёба является тяжёлым пороком развития челюстно-лицевой области с нарушением непрерывности верхней губы, альвеолярного отростка и нёба; порок сопровождается значимыми нарушениями питания, речи, слуха и носового дыхания.
- Расщепление и неправильное прикрепление нёбных мышц вызывают дисфункцию слуховой трубы, поэтому всем пациентам показаны наблюдение и лечение у оториноларинголога, при необходимости тимпанотомия, для профилактики и лечения экссудативного среднего отита и сохранения слуха.
- Реабилитация длится с рождения **до подросткового возраста** и требует участия команды:
  1. неонатолог и педиатр;
  2. челюстно-лицевой хирург и ортодонт;
  3. генетик;
  4. оториноларинголог;
  5. логопед и психолог.
- **Сроки операций**
  1. первичная хейлоринопластика: **старше 3–6 месяцев**, в течение первого года жизни;
  2. щадящая уранопластика при расщелине вторичного нёба: **1–2 года**;
  3. расщелина мягкого и твёрдого нёба: пластика мягкого нёба в **1–2 года**, щадящая уранопластика **после 3–4 лет**;
  4. устранение нёбно-глоточной недостаточности: **с 6 лет**;
  5. пластика альвеолярного отростка: **8–10 лет**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Расщелина верхней губы, альвеолярного отростка и нёба представляет собой врождённый порок развития с нарушением в средней зоне лица.

Составляющие порока

1. расщепление губы на два или три фрагмента;
2. деформация хрящевого отдела носа;
3. порочное прикрепление и нарушение функции пучков круговой мышцы рта;
4. дефект альвеолярного отростка верхней челюсти.

При расщелине нёба

1. сообщение полости рта с полостью носа через дефект по средней линии нёба;
2. неправильное расположение и прикрепление мышц мягкого нёба;
3. расширение среднего отдела глотки и укорочение мягкого нёба.

Реконструктивные операции

1. уранопластика: при расщелине твёрдого нёба;
2. пластика мягкого нёба: при расщелине мягкого нёба;
3. хейлоринопластика: при расщелине верхней губы и деформации хрящевого отдела носа.

Нарушения функций

1. питание: сосание невозможно из-за сообщения полостей носа и рта, затем нарушается жевание;
2. речь: несостоятельность велофарингеального сфинктера, невнятная тихая речь с носовым оттенком, задержка речевого развития;
3. слух: расщепление и неправильное прикрепление нёбной мускулатуры вызывают дисфункцию слуховой трубы;
4. носовое дыхание: деформация концевого и костно-хрящевого отдела носа нарушает воздушный поток и способствует патологии ЛОР-органов.

2.2 Этиология и эпидемиология

Порок имеет мультифакторное происхождение: генетическая предрасположенность или новая мутация сочетается с неблагоприятными факторами: физическими, химическими (дефицит питания, гипо- и гипервитаминоз, тератогенные вещества и лекарства, алкоголь, наркотики), биологическими (грипп, краснуха, герпес, токсоплазмоз).

Расщелины занимают 3–5-е место среди врождённых пороков и первое (87%) среди пороков лица; частота составляет 0,6–1,6 на 1000 новорождённых, в России около 1 на 650–700.

2.3 Классификация

1. односторонняя расщелина верхней губы: скрытая, неполная, полная;
2. двусторонняя расщелина верхней губы (симметричная, асимметричная): скрытая, неполная, полная;
3. односторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного отростка: неполная, полная;
4. двусторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного отростка: неполная, полная;
5. односторонняя полная расщелина верхней губы и нёба;
6. двусторонняя полная расщелина верхней губы и нёба;
7. расщелина нёба: субмукозная (скрытая), неполная, полная.

2.4 Клиническая картина

При полной расщелине губы всегда есть деформация кожно-хрящевого отдела носа. При односторонней расщелине крыло носа на стороне расщелины уплощено и растянуто, кончик носа смещён в больную сторону, перегородка носа выгнута в здоровую. При двусторонней расщелине перегородка носа короткая, кончик уплощён, крылья растянуты.

Скрытая (субмукозная) расщелина нёба малозаметна: иногда вдавление слизистой оболочки между половинами мягкого нёба, несращение костных пластинок твёрдого нёба, нёбо укорочено. Характерны открытая гнусавость и нарушения артикуляции, иногда компенсаторные движения мимических мышц и крыльев носа.

При полной расщелине мягкого и твёрдого нёба видны носовые раковины, слизистая оболочка их обычно гипертрофирована; мягкое нёбо укорочено, глоточное кольцо расширено, мышцы мягкого нёба недоразвиты.

---

3. Диагностика

Диагноз клинический и устанавливается на основании визуального осмотра, антропометрии, рентгенологических и ультразвуковых исследований. Специфической лабораторной диагностики нет: исследования назначает генетик, предоперационный комплекс исследований назначает педиатр.

3.1 Жалобы и анамнез

Во всех возрастных периодах уточняют

1. наследственный анамнез (патология челюстно-лицевой области);
2. воздействие тератогенов в I триместре беременности;
3. нарушения жевания, речи, дыхания и слуха, эстетический дефект.

3.2 Консультации специалистов

1. педиатр: общесоматический статус, росто-весовые показатели, сопутствующая патология перед плановой операцией;
2. челюстно-лицевой хирург: диагноз и план лечения;
3. оториноларинголог: состояние ЛОР-органов, профилактика осложнений;
4. ортодонт: состояние прикуса, ортодонтическая коррекция до и после операций;
5. генетик: генетическая патология, сопутствующие синдромы, планирование беременностей.

Оперативные вмешательства в подавляющем большинстве плановые, поэтому перед операцией пациента тщательно обследуют и компенсируют всю сопутствующую патологию; перед любым оперативным вмешательством оценивается степень анестезиологического риска.

3.3 Экссудативный средний отит

Пациентам с расщелиной губы и нёба показаны наблюдение и лечение у оториноларинголога, при необходимости тимпанотомия, для профилактики и лечения экссудативного среднего отита и сохранения слуха. Задачи оториноларинголога по возрастным периодам приведены в разделе «Медицинская реабилитация».

3.4 Риноскопия

Показания

1. дети **с 7 лет** — для выявления искривления перегородки носа и сообщения полости рта с полостью носа.

После риноскопии показана консультация оториноларинголога.

3.5 Фарингоскопия

Показания

1. дизартрия — для медико-логопедического исследования и разработки индивидуальной программы логопедической реабилитации.

Фарингоскопию выполняют челюстно-лицевой хирург и оториноларинголог, заключение даёт логопед.

3.6 Ультразвуковое скрининговое исследование при беременности

Показания

1. беременные **на 19–21-й неделе**: первичное выявление расщелин губы и нёба и других пороков развития лица, мозга, сердца и скелета.

3.7 Компьютерная томография челюстно-лицевой области

Показания

1. дети **6–11 лет**: оценка дефекта переднего отдела твёрдого нёба, положения фрагментов верхней челюсти и планирование размера костного трансплантата;
2. подростки **12–18 лет**: оценка соотношения верхней и нижней челюстей и определение показаний к ортогнатической операции.

4. Лечение

4.1 Консервативное лечение

Детям **0–3 месяцев** применяют ортодонтические аппараты (нёбные пластинки): они облегчают кормление, разделяют полости рта и носа и корригируют деформацию челюстей до операции. Затем проводится предхирургическое ортодонтическое лечение.

Логопедическая коррекция начинается в дооперационном периоде и продолжается после уранопластики. Семье показано психологическое консультирование для снижения тревожности.

4.2 Хирургическое лечение

Принципы

1. выбор метода по типу расщелины, степени гипоплазии и деформации окружающих структур;
2. восстановление анатомической и функциональной целостности зоны расщелины;
3. этапность лечения с учётом соматического статуса;
4. командный подход: челюстно-лицевой хирург и ортодонт.

Первичная хейлоринопластика устраняет дефект губы и деформацию носа. Рекомендуемый возраст: **старше 3–6 месяцев**, в течение первого года жизни.

Противопоказания к ранней пластике губы

1. сопутствующие врождённые пороки развития;
2. родовая травма;
3. постнатальная энцефалопатия;
4. анемия;
5. гипотрофия.

В этих случаях хейлоринопластику выполняют позднее, при достижении ремиссии.

Пластика нёба: рекомендуемый возраст

1. расщелина вторичного нёба: щадящая уранопластика в **1–2 года**;
2. расщелина мягкого и твёрдого нёба: два этапа, пластика мягкого нёба в **1–2 года**, щадящая уранопластика **после 3–4 лет**.

Нёбно-глоточную недостаточность устраняют для формирования правильной речи после консультации логопеда и оториноларинголога; коррекция целесообразна **с 6 лет**.

Пластику альвеолярного отростка выполняют в **8–10 лет** после ортодонтической подготовки.

Для устранения дефектов и деформаций после ранее проведённых операций применяют реконструктивную хейлоринопластику, хейлориносептопластику и повторную уранопластику.

Сроки корригирующих операций

1. верхняя губа: в любом возрасте;
2. кожно-хрящевой отдел носа: полная коррекция в **14–16 лет**;
3. деформация пирамиды носа: вмешательство откладывают **до 17 лет**.

Сроки коррекции носа определяют индивидуально с учётом тяжести патологии и социальной адаптации ребёнка.

Операции после 18 лет

1. ортогнатическая операция;
2. вторичная хейлоринопластика и риносептопластика;
3. повторная уранопластика и устранение нёбно-глоточной недостаточности;
4. пластика альвеолярного отростка, дентальная имплантация.

Задачи хирургического лечения односторонней расщелины губы и нёба

Проблема	Методики
смещение основания колумеллы и перегородки носа в здоровую сторону	мобилизация и репозиция переднего края четырёхугольного хряща (методики Millard, Козина, Delaire)
деформация крыльного хряща на стороне расщелины	мобилизация крыльного хряща, поднадкостничная мобилизация мышц назолабиального комплекса
укорочение нёба, дистопия мышц нёбно-глоточного кольца	удлинение нёба, восстановление мышечной структуры: Z-пластика по Furlow, методики Фроловой, Иванова — Агеевой, Veau — Wardill — Killner, Bardach

4.3 Медицинская реабилитация

Новорождённым показаны специальные приспособления для кормления. Зондовое питание не рекомендуется: оно подавляет рефлекс глотания и усугубляет недоразвитие челюстей и мышц мягкого нёба.

Показания к зондовому питанию

1. тяжёлая сопутствующая соматическая патология;
2. недоношенность;
3. незрелость новорождённого.

Первоочередной задачей является обучение родителей кормлению сцеженным грудным молоком или смесями и профилактика аспирации. В первые недели жизни необходим ежедневный контроль массы тела.

На первом году жизни росто-весовые показатели контролируют регулярно, **1 раз в неделю**, корректируя метод кормления и устраняя дефицит массы тела.

С периода новорождённости **до 18 лет** оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог на каждом этапе оценивают состояние среднего уха, рото- и носоглотки и слух; лечение симптоматическое, по показаниям.

Оценка ЛОР-органов и слуха по возрастным периодам

Возрастной период	Хирургический этап	Оценка ЛОР-органов и слуха
Период новорождённости	раннее ортодонтическое лечение в зависимости от типа расщелины	оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог оценивают среднее ухо, рото- и носоглотку, слух; симптоматическое лечение по показаниям
1–4 месяца	подготовка к операции, первичная хейлоринопластика (хейлориносептопластика)	оценка среднего уха, рото- и носоглотки, слуха; выявление противопоказаний к операции; симптоматическое лечение по показаниям
5–12 месяцев	первичная хейлоринопластика; подготовка к одноэтапной уранопластике или первый этап пластики нёба при двухэтапной операции	оценка среднего уха, рото- и носоглотки, слуха в послеоперационном периоде

Возрастной период	Хирургический этап	Оценка ЛОР-органов и слуха
12 месяцев – 2 года	одноэтапная уранопластика, второй этап пластики нёба при двухэтапной операции	сурдолог-оториноларинголог оценивает среднее ухо, рото- и носоглотку, слух в послеоперационном периоде
2–5 лет	устранение нёбно-глоточной недостаточности и дефектов твёрдого нёба, реконструктивная хейлоринопластика (хейлориносептопластика) по показаниям	сурдолог-оториноларинголог оценивает среднее ухо, рото- и носоглотку, слух в послеоперационном периоде
6–11 лет	устранение расщелины альвеолярного отростка и нёбно-глоточной недостаточности, хейлоринопластика, уранопластика	оценка среднего уха, рото- и носоглотки, слуха в послеоперационном периоде
12–18 лет	устранение сочетанной деформации челюстей, расщелины альвеолярного отростка и нёбно-глоточной недостаточности, хейлоринопластика, дентальная имплантация	оториноларинголог оценивает среднее ухо, рото- и носоглотку в предоперационном периоде

> В таблице 7 второй этап пластики нёба при двухэтапной операции отнесён к периоду от 12 месяцев до 2 лет, тогда как в разделе 3.2 щадящая уранопластика вторым этапом рекомендована после 3–4 лет.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Медицинская помощь оказывается в стационарных условиях, в том числе высокотехнологичная. Госпитализация плановая, поэтапная, согласно алгоритму лечения.

5.2 Диспансерное наблюдение

Диспансерное наблюдение проводится **с рождения до 18 лет** включительно.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Одно- и двусторонняя расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого нёба»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 17.06.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июня 2029 года
Код в рубрикаторе	`1050_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки операций в разделе 3.2 и в приложении В («Информация для пациента») расходятся: пластика альвеолярного отростка в 8–10 лет и «начиная с 7 лет», хейлоринопластика «старше 3–6 мес» и «в течение первых четырех-шести месяцев», уранопластика в 1–2 года и «от 13 месяцев».

- Второй этап пластики нёба при двухэтапной операции в таблице 7 отнесён к возрасту от 12 месяцев до 2 лет, в разделе 3.2 рекомендован после 3–4 лет.

Клинические рекомендации

Саркоидоз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D86.0** — Саркоидоз легких **D86.1** — Саркоидоз лимфатических узлов **D86.2** — Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов **D86.3** — Саркоидоз кожи **D86.8** — Саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций **D86.9** — Саркоидоз неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Российское Общество Фтизиатров; Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов" ; Российское респираторное общество; Общероссийская общественная организация Педиатрическое респираторное общество
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/736_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Саркоидоз является системным воспалительным заболеванием неизвестной этиологии, при котором образуются неказеифицирующиеся гранулёмы, поражаются многие органы и активируются Т-клетки в очагах воспаления.
- Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта составляет менее 1% случаев. Формы поражения:
  1. синоназальная: заложенность носа, корки, носовые кровотечения, узелки на перегородке и верхней раковине;
  2. увеличение нёбных миндалин;
  3. поражение гортани с риском обструкции;
  4. сенсоневральная или кондуктивная тугоухость.

  Диагноз требует биопсии.
- Синдром Хеерфордта — Вальденстрёма: увеличение околоушных слюнных желёз, передний увеит, лихорадка, иногда паралич лицевого нерва.
- Диагноз верифицируется морфологически: гранулёмы без казеозного некроза хотя бы в одном органе при характерной клинико-рентгенологической картине; синдромы Лёфгрена, Хеерфордта, ознобленная волчанка позволяют установить предположительный диагноз без биопсии.
- Бессимптомным пациентам без недостаточности органов показано активное наблюдение с оценкой **через 3 месяца**; системные глюкокортикоиды показаны при прогрессировании, угрозе функции органа или жизни.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Саркоидоз является системным воспалительным заболеванием неизвестной этиологии, характеризующимся образованием неказеифицирующихся гранулём, мультисистемным поражением различных органов и активацией Т-клеток в месте гранулёматозного воспаления с высвобождением различных хемокинов и цитокинов.

Синдром Лёфгрена является вариантом острого течения саркоидоза, проявляющимся внутригрудной лимфаденопатией, узловатой эритемой, суставным синдромом и лихорадкой.

Синдром Хеерфордта — Вальденстрёма является вариантом острого течения саркоидоза, проявляющимся увеитом, паротитом, лихорадкой и в ряде случаев сопровождающимся параличом лицевого нерва (паралич Белла).

Саркоидная реакция представляет собой образование локализованных групп эпителиоидно-клеточных неказеифицирующихся гранулём саркоидного типа в ответ на экзогенные факторы (импланты, татуировки, филлеры), при применении интерферонов, перифокально при злокачественных опухолях и паразитарных заболеваниях; в отличие от саркоидоза поражение только локальное.

2.2 Этиология и эпидемиология

Решающую роль играет воздействие окружающей среды на генетически предрасположенный организм. Вероятными триггерами являются изменённые микобактерии, пропионовокислые бактерии, боррелии; саркоидная реакция возможна при применении интерферонов, индукторов интерфероногенеза и таргетной биологической терапии.

Саркоидоз встречается во всех возрастах и у обоих полов; в России преобладают женщины молодого и зрелого возраста. Синдром Лёфгрена наблюдается в 3,7–22% случаев, семейный саркоидоз в среднем в 9,5%.

2.3 Классификация

Классификация внутригрудного саркоидоза по данным лучевого обследования

Стадия	Рентгенологическая картина	Частота
0	нет изменений на рентгенограмме органов грудной клетки	5%
I	увеличение внутригрудных лимфатических узлов, паренхима лёгких не изменена	45%
II	увеличение внутригрудных лимфатических узлов и изменения паренхимы лёгких	30%
III	изменения паренхимы без увеличения внутригрудных лимфатических узлов	15%
IV	выраженный фиброз лёгких как ведущий синдром	5%

Рентгенологическая стадия не отражает стадийность клинического течения; КТ точнее характеризует распространённость изменений. В диагнозе перечисляют все поражённые органы и системы.

Фенотипы (клинико-патогенетические варианты) саркоидоза

1. **по локализации**: классический, с преобладанием внутригрудных (лёгочных) поражений; с преобладанием внелёгочных поражений; генерализованный;
2. **по особенностям течения**: с острым началом (синдромы Лёфгрена, Хеерфордта — Вальденстрёма), с изначально хроническим течением, с фиброзированием, рецидив, саркоидоз детей моложе 5 лет, саркоидоз, рефрактерный к лечению системными глюкокортикоидами.

Обострением называют реактивацию **в течение года** после окончания основного курса лечения, рецидивом считают возобновление проявлений **через 1 год и более** после лечения или спонтанной регрессии.

Признаки прогрессирования

1. ухудшение клиники, нарастание изменений в лёгких на КТ;
2. появление или усиление внелёгочных проявлений;
3. снижение ФЖЕЛ на **10% и более** или DLco на **15%** за 1 год;
4. формирование лёгочной гипертензии;
5. повышение АПФ, гиперкальциурия и (или) гиперкальциемия.

Построение диагноза

1. локализация (поражённые органы), при внутригрудном саркоидозе рентгенологическая стадия 0–IV;
2. активность: 0 (неактивный), 1 (активный) (или «синдром Лёфгрена», «синдром Хеерфордта — Вальденстрёма»);
3. течение: стабильное, прогрессирующее, регрессирующее, волнообразное, обострение, рецидив;
4. осложнения: недостаточность органа, стойкие структурные изменения;
5. подтверждение диагноза на клеточном или тканевом уровне.

2.4 Клиническая картина

Чаще течение малосимптомное, хроническое. Наиболее выражены жалобы при синдроме Лёфгрена и при «увеопаротидной лихорадке» (синдроме Хеерфордта — Вальденстрёма).

Синдром Лёфгрена (как правило, не дольше 2 месяцев)

1. лихорадка;
2. узловатая эритема;
3. двусторонний периартрит, преимущественно голеностопных суставов;
4. двусторонняя лимфаденопатия корней лёгких.

Общие симптомы

1. слабость и утомляемость (30–80%), оцениваются по шкале FAS;
2. лихорадка (20–60%) или длительный субфебрилитет;
3. боль, тревога, депрессия, когнитивная дисфункция, нейропатия мелких волокон.

При поражении лёгких и внутригрудных лимфатических узлов возникают боль и дискомфорт в грудной клетке, одышка (оценивается по шкале mMRC), сухой кашель из-за давления увеличенных лимфатических узлов на бронхи или раздражения гранулёмами нервных окончаний.

2.5 Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта

Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта составляет менее 1% случаев саркоидоза; чаще всего это случайные находки.

Формы поражения

1. **синоназальный саркоидоз** проявляется неспецифическими симптомами: заложенностью носа, ринореей, корками на слизистой оболочке, носовыми кровотечениями, болью в носу, нарушением обоняния. Эндоскопически выявляется картина хронического риносинусита с узлами на перегородке и (или) в носовых раковинах, корками и мелкими саркоидозными узелками, чаще на перегородке и верхней носовой раковине. Диагноз требует гистологической верификации;
2. **саркоидоз нёбных миндалин** может проявляться бессимптомным одно- или двусторонним увеличением миндалин; неказеифицирующиеся гранулёмы в их ткани выявляются после тонзиллэктомии;
3. **саркоидоз гортани** приводит к дисфонии, дисфагии, кашлю. Обнаруживают отёк и эритему слизистой оболочки, узелки и узлы. Диагноз подтверждается биопсией. Возможна угрожающая жизни обструкция дыхательных путей;
4. **саркоидоз уха** относится к особо редким локализациям и обычно сочетается с поражением других органов. Проявляется снижением слуха, шумом в ушах, глухотой, вестибулярными расстройствами; вызывает сенсоневральную тугоухость разной степени, реже — поражение среднего уха с кондуктивной тугоухостью;
5. **саркоидоз полости рта и языка** встречается нечасто и проявляется опуханием и изъязвлением слизистой оболочки полости рта, языка, губ, дёсен. Орофарингеальный саркоидоз может быть причиной ночного обструктивного апноэ, в том числе как единственное проявление заболевания.

Саркоидоз слюнных желёз (6%) проявляется двусторонним опуханием околоушных желёз, в том числе в составе синдрома Хеерфордта — Вальденстрёма.

Дифференциальная диагностика

1. хронический сиалоаденит;
2. туберкулёз;
3. болезнь кошачьей царапины;
4. актиномикоз;
5. синдром Шегрена.

Поражение черепных нервов является самым частым проявлением нейросаркоидоза (50% случаев), чаще всего лицевого, затем зрительного нерва. Паралич лицевого нерва обычно проходит за несколько месяцев даже без лечения. Описаны потеря слуха (VIII нерв), лицевая боль и нарушения чувствительности (V нерв).

Озноблённая волчанка (lupus pernio) представляет собой хроническое рецидивирующее поражение кожи носа, щёк, ушных раковин и пальцев. Поражённые участки уплотнены; их цвет красный, пурпурный или фиолетовый. Часто сочетается с поражением лёгких, костей и глаз и резистентна к лечению.

Периферические лимфатические узлы поражаются в 10–25%, чаще задние и передние шейные и надключичные: плотноэластические, не размягчаются и не образуют свищей. Обнаружение эпителиоидно-клеточных гранулём в удалённом узле требует дифференциальной диагностики с саркоидной реакцией и другими гранулематозами.

2.6 Внелёгочные локализации

Кожа (10–30%): узлы, бляшки, «ожившие рубцы», гранулёмы в татуировках; узловатая эритема саркоидных гранулём не содержит. Глаза (5–25%): передний (70–75%) и задний увеит, которые требуют офтальмологического обследования. У детей до 5 лет характерна триада: увеит, поражение кожи, артрит без поражения лёгких.

Сердце (2–18%) является жизнеугрожающей локализацией: нарушения ритма и проводимости, внезапная смерть. Поражение нервной системы (5–10%) проявляется краниальными нейропатиями, асептическим менингитом, гипоталамо-гипофизарной дисфункцией. Возможно также поражение почек, печени, селезёнки, костей (кистоидный остеит фаланг), суставов.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается по жалобам, анамнезу, лучевым, функциональным, лабораторным и морфологическим данным и требует исключения саркоидной реакции и сходных заболеваний. Диагноз верифицируется выявлением гранулём без казеозного некроза хотя бы в одном органе при характерной клинико-рентгенологической картине.

Синдром Лёфгрена, синдром Хеерфордта, озноблённая волчанка и бессимптомная двусторонняя внутригрудная лимфаденопатия настолько специфичны, что позволяют установить предположительный диагноз без морфологического исследования.

Диагноз устанавливает и формулирует пульмонолог медицинской организации 2–3 уровня после обследования.

3.2 Физикальное обследование

Показания

1. все пациенты: обследование всех органов и систем.

Диагностические признаки

1. изменения кожи, особенно в области старых рубцов и татуировок;
2. безболезненные подвижные увеличенные периферические лимфатические узлы, подкожные саркоиды Дарье — Русси;
3. увеит, эписклерит при осмотре конъюнктивы и радужки;
4. увеличение печени и селезёнки.

3.3 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. все пациенты.

Диагностические признаки

1. повышение СОЭ при остром течении;
2. лимфопения и моноцитоз как признаки активности;
3. тромбоцитопения при поражении печени, селезёнки, костного мозга.

3.4 Оценка функции почек

Показания

1. все пациенты: при первичной диагностике и **не реже 1 раза в 6 месяцев**.

Исследования

1. общий анализ мочи;
2. креатинин и мочевина крови;
3. скорость клубочковой фильтрации (СКФ).

3.5 Активность ангиотензинпревращающего фермента

Показания

1. подростки и взрослые: при выявлении и в динамике как маркер активности, но не как дифференциально-диагностический критерий.

Диагностические признаки

1. норма **в 6–18 лет**: **29–112 ед.**;
2. норма **старше 18 лет**: **20–70 ед.**;
3. клинически значимым является увеличение активности **более 150%** от верхней границы нормы.

3.6 С-реактивный белок

При остром саркоидозе определяют С-реактивный белок: его умеренное повышение характерно для синдрома Лёфгрена.

3.7 Кальций крови и суточной мочи

Кальций крови и суточной мочи исследуют при выявлении и в динамике: гиперкальциемия (5%) и гиперкальциурия (25%) являются признаками активного процесса.

3.8 Иммуноглобулины A, M, G

Иммуноглобулины A, M, G определяют при первичном обследовании для дифференциальной диагностики с иммунодефицитами, сопровождающимися гранулёмами (ОВИН).

3.9 Исключение туберкулёза

1. детям **до 7 лет** на этапе первичной диагностики проводят пробу Манту с 2 ТЕ; у не получавших системные глюкокортикоиды при активном саркоидозе она отрицательна не менее чем в 80–85% случаев;
2. всем пациентам при первичной диагностике обязательна проба с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным (АТР);
3. при отказе от кожных проб или невозможности их выполнения проводят IGRA-тесты;
4. при положительном результате показано углублённое обследование у фтизиатра.

Проба с АТР не проводится, если пациент получает иммуносупрессивную терапию.

3.10 Рентгенография органов грудной полости

Показания

1. все пациенты: первичная диагностика и определение стадии;
2. динамическое наблюдение: только при невозможности КТ.

Диагностические признаки

1. симметричное увеличение лимфатических узлов корней лёгких и средостения;
2. двусторонние очагово-интерстициальные изменения при относительно удовлетворительном состоянии.

3.11 Компьютерная томография органов грудной полости

Показания

1. все пациенты: первичная диагностика и динамическое наблюдение.

Диагностические признаки

1. увеличенные лимфатические узлы центрального средостения и корней лёгких без перифокальной инфильтрации;
2. перилимфатические мелкие очаги вдоль бронхососудистых пучков, междолевых щелей и плевры.

3.12 Другие методы визуализации

Показания

1. МРТ сердца и (или) головного мозга: подозрение на саркоидоз сердца и центральной нервной системы;
2. ПЭТ-КТ всего тела: уточнение локализации и выбор места биопсии (накопление ФДГ не отличает саркоидоз от опухоли или инфекции).

Исследования при подозрении на генерализованный или внелёгочный саркоидоз

1. УЗИ брюшной полости;
2. МРТ головного мозга и сердца;
3. эхокардиография;
4. рентгенография и МРТ поражённых костей и мягких тканей.

3.13 Исследование функции внешнего дыхания

Показания

1. все пациенты при первичной диагностике вне зависимости от локализации;
2. активная фаза: **не реже 1 раза в 3 месяца**;
3. динамическое наблюдение: ежегодно.

Методы

1. спирометрия (ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ);
2. диффузионная способность лёгких (DLco) в пульмонологических центрах;
3. пульсоксиметрия на всех этапах, при необходимости тест с 6-минутной ходьбой.

3.14 Электрокардиография

ЭКГ является обязательным компонентом первичного обследования; при нарушениях ритма показано холтеровское мониторирование.

3.15 Биопсия

Показания

1. все пациенты на этапе первичной диагностики: бронхоскопия с биопсией.

Методы биопсии (выбирают по ситуации)

1. прямая;
2. чрезбронхиальная;
3. тонкоигольная биопсия лимфатических узлов;
4. криобиопсия.

Всем пациентам обязательно исключение туберкулёза в биоптатах и промывных водах бронхов: микроскопия, посев, ПЦР.

При неинформативности эндоскопической биопсии выполняются миниинвазивные хирургические вмешательства: видеоторакоскопическая резекция лёгкого, биопсия внутригрудных лимфатических узлов.

При внелёгочном саркоидозе выполняется биопсия поражённого органа: периферического лимфатического узла, кожи, подкожных образований, печени. Метод выбирают лечащий врач и хирург.

3.16 Дифференциальная диагностика

1. **внутригрудная лимфаденопатия**: туберкулёз, нетуберкулёзный микобактериоз, бруцеллёз, токсоплазмоз, болезнь Кикучи, болезнь кошачьей царапины, саркоидная реакция при карциноме, лимфомы, острый лимфобластный лейкоз, GLUS-синдром, IgG4-ассоциированное заболевание, ОВИН;
2. **диссеминация в лёгких**: туберкулёз, микозы, опухолевая диссеминация, гиперчувствительный пневмонит, пневмокониозы, лекарственные реакции, гистиоцитоз X, гранулематоз с полиангиитом (Вегенера), интерстициальные пневмонии, ОВИН;
3. **дети до 5 лет**: увеиты, паротиты, артриты и поражения кожи другой этиологии.

---

4. Лечение

Этиотропной терапии нет. Активная терапия показана при угрозе недостаточности органов, угрозе жизни или потере качества жизни; в остальных случаях проводится активное наблюдение. Необходимость лечения соотносят с тяжестью последствий глюкокортикоидной, цитостатической или биологической терапии.

4.1 Активное наблюдение

Бессимптомным пациентам (детям и взрослым) без недостаточности органов показано активное наблюдение с оценкой **через 3 месяца**, поскольку частота спонтанных ремиссий высока.

Взрослым с бессимптомным течением без функциональных нарушений в качестве альтернативы возможно назначение #альфа-токоферола ацетата или его сочетания с #пентоксифиллином на срок не менее **6 месяцев**. Дозы в тексте рекомендации противоречивы (мкг и мг); варианты приведены в «Подробнее».

1. #альфа-токоферола ацетат: в разделе 3.1 указано «200 мкг 2 раза в сутки» и, ниже, «200–400 мг в сутки»;
2. #пентоксифиллин: в разделе 3.1 указано «400–2000 мкг в сутки» и, ниже, 600–1200 мг в сутки (при стероидзамещающей терапии до 2000 мг).

4.2 Системные глюкокортикоиды

СГКС являются препаратами первой линии при прогрессирующем течении болезни, но только при выраженных симптомах или внелёгочных проявлениях, нарушающих функцию органа, при развитии lupus pernio, угрозе жизни или резком снижении качества жизни. Риск нежелательных явлений высокий.

1. преднизолон, взрослым: внутрь утром 20–40 мг в сутки (0,5 мг/кг) **4 недели**, затем снижение по 5 мг в месяц до минимальной поддерживающей дозы; общая длительность приёма **12–24 месяца**.

Эффект оценивают **через 3 месяца**, при его отсутствии переходят на альтернативную терапию. Препараты СГКС следует применять **не менее 10–12 месяцев**. После отмены обострения развиваются у 30–80%. О полной ремиссии судят **через 3 года** после прекращения терапии.

При отсутствии эффекта **через 3–6 месяцев** и при прогрессировании следует пересмотреть диагноз и исключить инфекционную, прежде всего туберкулёзную, природу изменений. При рецидиве после полноценного курса СГКС показаны препараты второй линии, предпочтительно метотрексат.

Нежелательные явления: повышение артериального давления и уровня глюкозы крови, увеличение массы тела, остеопороз (лечение бисфосфонатами), надпочечниковая недостаточность.

4.3 Ингаляционные глюкокортикоиды

Показания

1. саркоидоз гортани;
2. выраженный кашель.

В качестве основной терапии саркоидоза ингаляционные глюкокортикоиды не рекомендуются. Комбинации с бронхолитиками применяют только при доказанной обратимой бронхообструкции.

4.4 Препараты второй и третьей линии

#Метотрексат применяют как препарат второй линии (при рефрактерности к СГКС, побочных реакциях или для снижения их дозы) и как препарат первой линии в монотерапии или в комбинации с СГКС при верифицированном саркоидозе. Обладает тератогенностью, противопоказан при беременности.

1. #метотрексат: внутрь 10–15 мг 1 раз в неделю; взрослым при нейро- и кардиосаркоидозе до 25 мг в неделю;
2. #фолиевая кислота: 5 мг 1 раз в неделю или 1 мг ежедневно, не ранее чем через 24 часа после метотрексата; терапия от 6 месяцев.

До лечения определяют АЛТ, АСТ, креатинин, общий анализ крови; в ходе лечения исследования повторяют **каждые 1–3 месяца**.

Другие препараты второй линии

Препарат	Режим дозирования	Возрастные ограничения	Нежелательные явления и противопоказания
#Азатиоприн	100–200 мг в сутки, не менее 6 месяцев	с 3 лет	гепатотоксичность, лейкопения, инфекции, повышение риска лимфомы и лейкемии
#Лефлуномид	10–20 мг в сутки; эффект не ранее чем через 3 месяца	с 18 лет	тератогенен, противопоказан при беременности; общий и биохимический анализ крови до лечения и каждые 1–3 месяца

Препарат	Режим дозирования	Возрастные ограничения	Нежелательные явления и противопоказания
#Микофенолата мофетил	500 мг 2 раза в день с увеличением до 750–1000 мг 2 раза в день	с 12 лет (площадь поверхности тела 1,25 м^2)	у каждого пятого пациента тошнота, диарея, лейкопения, повышение риска инфекций; регулярный общий анализ крови
#Циклофосфамид	500–1000 мг внутривенно каждые 3–4 недели при полиорганном поражении и рефрактерности	дети и взрослые	чаще других иммунодепрессантов вызывает инфекционные осложнения
#Гидроксихлорохин	400 мг с возможным снижением до 200 мг в сутки, 6–12 месяцев	с 6 лет	не рекомендуется при саркоидозе глаз (ретинопатия); удлиняет интервал QT, необходим регулярный ЭКГ-контроль; противопоказан при беременности

Ингибиторы ФНО-альфа применяют в третьей линии только при рефрактерном саркоидозе в профильных центрах.

1. #инфликсимаб: 3 или 5 мг/кг внутривенно на 0-й, 2-й и 6-й неделе, затем каждые 4–8 недель;
2. #адалимумаб: 40 мг в неделю.

НПВП применяют симптоматически при острых формах и артритах с выраженным болевым синдромом, по инструкции.

Антифибротическая терапия показана только взрослым при прогрессирующем фиброзе, несмотря на лечение глюкокортикоидами и препаратами второй линии.

4.5 Другие методы лечения

При хроническом рефрактерном саркоидозе применяют плазмаферез (3–4 процедуры с недельным перерывом) или экстракорпоральную модификацию лимфоцитов.

Трансплантация лёгких показана при терминальной стадии (IV, фиброз), сердца при кардиосаркоидозе с рефрактерными нарушениями ритма, печени при её тяжёлом поражении.

При дыхательной недостаточности применяют низкопоточную оксигенотерапию, в тяжёлых случаях неинвазивную ИВЛ до SpO_2 более 90%; лечение лёгочной гипертензии проводится по рекомендациям по лёгочной артериальной гипертензии.

Немедикаментозные программы для всех пациентов

1. повышение физической активности;
2. физическая и психологическая реабилитация;
3. группы поддержки;
4. лечение боли и нарушений сна.

Разгрузочно-диетическая терапия рекомендована пациентам на ранних стадиях саркоидоза при наличии ожирения.

Компоненты медицинской реабилитации

1. лечебный режим;
2. диетотерапия;
3. физическая реабилитация (активная и пассивная);
4. респираторная физиотерапия;
5. психодиагностика и психокоррекция.

Утверждённой программы медицинской реабилитации при саркоидозе не разработано.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

1. **плановая госпитализация**: первичная комплексная, в том числе инвазивная, диагностика и подбор начальной терапии;
2. **экстренная госпитализация**: острый прогрессирующий саркоидоз с осложнениями (дыхательная недостаточность, нарушения ритма).

В большинстве случаев лечение проводится амбулаторно.

Критерии выписки

1. завершение диагностики и установление клинического диагноза;
2. назначение лечения;
3. компенсация острого состояния и осложнений, ставших причиной госпитализации.

5.2 Диспансерное наблюдение

Наблюдение пожизненное: при торакальных формах его осуществляет пульмонолог, при генерализованных и внеторакальных пульмонолог и специалист по соответствующей локализации.

Частота осмотров

1. впервые выявленный саркоидоз в первый год болезни и при сохранении активности процесса: **каждые 3 месяца**;
2. при стабилизации процесса на 2-м году: **каждые 6 месяцев**, в последующие годы — ежегодно;
3. при рецидивах: каждые 3 месяца в течение **2 лет**, в последующие годы при стабилизации — ежегодно;
4. при прогрессирующем течении: каждые 3 месяца в течение **2 лет**, затем при стабилизации процесса каждые 6 месяцев в течение **2 лет**, затем ежегодно.

Пациенты с саркоидозом относятся к иммунокомпрометированным; вакцинация проводится по национальному календарю и календарю по эпидемическим показаниям с учётом периода болезни и терапии.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Саркоидоз»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	736_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское респираторное общество; Российское научное медицинское общество терапевтов; Педиатрическое респираторное общество; Российское

	общество фтизиатров; Российское общество рентгенологов и радиологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Дозы #альфа-токоферола ацетата и #пентоксифиллина в разделе 3.1 указаны в микрограммах («200 мкг 2 раза в сутки», «400–2000 мкг»), а ниже в том же разделе — в миллиграммах («200–400 мг в сутки», «600 мг в сутки», «до 2000 мг»); различие в тысячу раз.

Клинические рекомендации

Сифилис

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**A50** — Врожденный сифилис **A51** — Ранний сифилис **A52** — Поздний сифилис **A53** — Другие и неуточненные формы сифилиса
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 09.07.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/197_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Сифилис — инфекция, вызываемая бледной трепонемой и передающаяся преимущественно половым путём; течение стадийное, рецидивирующее, прогрессирующее.
- **Поражения ЛОР-органов и полости рта**
  1. атипичный первичный аффект — шанкр-амигдалит: одностороннее увеличение и уплотнение нёбной миндалины;
  2. вторичный период — розеолёзные и папулёзные сифилиды слизистых оболочек, боль в горле;
  3. третичный период — бугорковые и гуммозные сифилиды с дефектами тканей;
  4. врождённый сифилис — специфический ринит у грудных детей; лабиринтная глухота в триаде Гетчинсона, деформации носа.
- Абсолютное доказательство — бледная трепонема или её ДНК/РНК в отделяемом очагов. Основа диагностики — сочетание нетрепонемного (РМП/RPR) и трепонемного тестов; при отологической симптоматике показана спинномозговая пункция для исключения нейросифилиса.
- Препарат первого выбора — бензилпенициллин. Превентивное лечение контактных с ранним сифилисом — **не позднее 2 месяцев** после контакта: бензатина бензилпенициллин 2,4 млн ЕД в/м однократно.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Сифилис — инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой (Treponema pallidum), передающееся преимущественно половым путём, со стадийным, рецидивирующим, прогрессирующим течением.

Поражаются

1. кожа и слизистые оболочки;
2. нервная система;
3. внутренние органы;
4. опорно-двигательный аппарат.

Treponema pallidum — спиралевидный микроорганизм, не культивируется на искусственных средах; вне организма неустойчива, гибнет при нагревании, высушивании, под действием антисептиков; устойчива при низких температурах и во влажной среде.

2.2 Классификация

Приобретённый сифилис

1. **первичный** — серонегативный и серопозитивный; при внеполовой локализации шанкра — «экстрагенитальный»
2. **вторичный** — свежий (обильные мелкие симметричные сифилиды и остатки первичного аффекта) и рецидивный (немногочисленные крупные сгруппированные сифилиды)
3. **третичный** — активный (бугорковые и гуммозные сифилиды) и скрытый
4. **скрытый** — ранний (давность **до 2 лет**), поздний (**более 2 лет**), неуточнённый
5. **нейросифилис** — ранний (**до 5 лет**) и поздний (**более 5 лет**), асимптомный и манифестный
6. **сифилис внутренних органов и опорно-двигательного аппарата** — ранний и поздний

1. **ранний врождённый** — у детей **до 2 лет**: активный или скрытый
2. **поздний врождённый** — у детей **старше 2 лет**: активный или скрытый

Граница между ранними и поздними формами — **2 года** с момента заражения: до этого срока пациент эпидемиологически опасен, а бугорки и гуммы, как правило, не появляются.

2.3 Клиническая картина

Инкубационный период в среднем **от 2 недель до 2 месяцев**, крайние значения — 8 и 190 дней.

Первичный аффект (твёрдый шанкр)

1. эрозия или язва от 2–3 мм до 1,5–2 см и более, круглая, с ровными краями;
2. дно гладкое, блестящее, отделяемое скудное серозное;
3. безболезненная, с плотноэластическим инфильтратом в основании;
4. безболезненный регионарный лимфаденит.

Первичный период длится в среднем **6–7 недель**.

1. **шанкр-амигдалит** — одностороннее увеличение и уплотнение нёбной миндалины
2. **шанкр-панариций** — болезненная язва на отёчной концевой фаланге пальца
3. **индуративный отёк** — одностороннее увеличение половой губы или отёчность крайней плоти

Вторичный период наступает **через 2–3 месяца** после инфицирования; пациенты могут жаловаться на повышение температуры, головную боль, утомляемость, боль в горле.

Проявления

1. розеолёзные и папулёзные, реже папуло-пустулёзные высыпания на коже;
2. на слизистых оболочках — сифилиды от опаловых папул до эрозивных, вегетирующих, рагадиформных, редко язвенных;
3. сифилитическая лейкодерма и алопеция.

Третичный сифилис развивается, как правило, после скрытого периода, спустя многие годы после заражения.

1. бугорковые и гуммозные сифилиды, третичная розеола Фурнье на коже и видимых слизистых оболочках, часто с дефектами тканей;
2. поражения внутренних органов, костей и суставов;
3. поражение нервной системы.

1. **ранний врождённый** — патогномоничны сифилитический пемфигоид, диффузная инфильтрация кожи Гохзингера, специфический ринит (сухая, катаральная и язвенная стадии), остеохондрит Вегнера
2. **поздний врождённый** — достоверные признаки — триада Гетчинсона: паренхиматозный кератит, лабиринтная глухота, зубы Гетчинсона; вероятные — саблевидные голени, деформации носа, лучистые рубцы вокруг рта, «готическое» нёбо

Кроме того, при позднем врождённом сифилисе характерны бугорковые и гуммозные сифилиды кожи и слизистых оболочек.

Нейросифилис может проявляться головной болью, головокружением, тошнотой, нарушением зрения, слуха, речи, судорогами, нарушением координации. Ранние формы — менинговаскулярный сифилис, сифилитический увеит; поздние — прогрессирующий паралич, спинная сухотка, атрофия зрительных нервов, гуммозный нейросифилис.

---

3. Диагностика

3.1 Прямые методы

Абсолютным доказательством является обнаружение бледной трепонемы в образцах из очагов поражения или её ДНК/РНК методом ПЦР.

Методы

1. микроскопия в тёмном поле;
2. прямая иммунофлюоресценция;
3. ПЦР.

Прямые методы применяют при ранних формах с эрозивно-язвенными элементами и для подтверждения врождённого сифилиса, в том числе в отделяемом слизистой оболочки носа.

3.2 Серологическая диагностика

1. **массовый скрининг** — нетрепонемные тесты (РМП, RPR, VDRL)
2. **особые группы (беременные, доноры и др.)** — комбинация нетрепонемного и трепонемного тестов
3. **контактные при давности контакта** не более 2 месяцев — один из трепонемных тестов

1. **ранние манифестные формы** — нетрепонемный тест количественно + трепонемный (РПГА, ИФА, иммуноблоттинг)
2. **скрытые и поздние формы, ложноположительные результаты** — нетрепонемный тест количественно + трепонемные

У ВИЧ-инфицированных результаты интерпретируют по тем же алгоритмам.

3.3 Спинномозговая пункция

Показания к исследованию цереброспинальной жидкости (ВИЧ-отрицательные пациенты)

1. неврологическая, офтальмологическая, отологическая симптоматика или психические расстройства — независимо от стадии;
2. скрытые и поздние формы;
3. злокачественное течение раннего сифилиса; вторичный сифилис с лейкодермой и алопецией;
4. специфические поражения внутренних органов; подозрение на врождённый сифилис;
5. отсутствие негативации нетрепонемных тестов после лечения ранних форм; нарастание титра при контроле после лечения поздних форм.

ВИЧ-инфицированным пункция показана также при титре РМП/RPR ≥ 1:32 и CD4+ ≤ 350 клеток/мкл.

3.4 Другие исследования

1. **всем, кроме первичного сифилиса** — биохимический анализ крови с печёночными показателями
2. **всем** — антитела к ВИЧ-1/2, HBsAg, антитела к вирусу гепатита С
3. **нейросифилис** — МРТ и КТ головного мозга, ЭЭГ
4. **висцеральный сифилис** — эхокардиография, КТ и МРТ внутренних органов, ЭКГ и др.

---

4. Лечение

4.1 Препараты

Препаратом первого выбора является бензилпенициллин. Применяют также бензатина бензилпенициллин (дюрантный), его комбинацию с бензилпенициллином прокаина, доксициклин, эритромицин, цефтриаксон.

Превентивное лечение проводят лицам после полового или тесного бытового контакта с больным ранним сифилисом, если с момента контакта прошло **не более 2 месяцев**. Препарат выбора — бензатина бензилпенициллин 2,4 млн ЕД в/м однократно (по 1,2 млн ЕД в каждую ягодичную мышцу).

4.2 Лечение взрослых по формам

Схемы лечения взрослых

Форма	Схемы
Первичный	бензатина бензилпенициллин 2,4 млн ЕД в/м 1 раз в 5 дней, 3 инъекции; или бензилпенициллина новокаиновая соль 600 тыс. ЕД 2 раза в сутки 14 дней; или натриевая соль 1 млн ЕД каждые 4 часа 14 дней
Вторичный	бензилпенициллина натриевая соль 1 млн ЕД каждые 4 часа 28 дней; или новокаиновая соль 600 тыс. ЕД 2 раза в сутки; или бензатина бензилпенициллин 2,4 млн ЕД 1 раз в 5 дней, 6 инъекций
Ранний скрытый	бензилпенициллина натриевая соль 1 млн ЕД в/м 28 дней; или новокаиновая соль 600 тыс. ЕД 2 раза в сутки 28 дней
Третичный, поздний и неуточнённый скрытый	бензилпенициллин 28 дней, через 2 недели — второй курс 14 дней
Ранний нейросифилис	бензилпенициллина натриевая соль 12 млн ЕД 2 раза в сутки в/в капельно 20 дней или 4 млн ЕД 6 раз в сутки в/в струйно 20 дней
Поздний нейросифилис	те же схемы в/в, через 2 недели — второй курс

Пероральные препараты при поздних формах менее эффективны и часто ведут к серологической резистентности; их допускают лишь при непереносимости всех парентеральных препаратов.

Манифестный нейросифилис лечат в неврологическом или психиатрическом стационаре.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Ведение контактных

1. **контакт** не более 2 месяцев **назад** — превентивное лечение
2. 2–4 месяца — двукратное клинико-серологическое обследование с интервалом 2 месяца
3. более 4 месяцев — однократное обследование
4. **переливание крови больного** — не более 3 месяцев — лечение по схеме первичного сифилиса; 3–6 месяцев — двукратный контроль; более 6 месяцев — однократное обследование

Антенатальная профилактика врождённого сифилиса включает трёхкратное серологическое обследование беременных: при обращении в женскую консультацию, **на сроке 28–30 недель** и **за 2–3 недели до родов**.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. беременные, нуждающиеся в специфическом и профилактическом лечении;
2. дети с врождённым сифилисом;
3. дети с приобретённым сифилисом **до 10 лет** и (или) при соматической патологии;
4. пациенты, которым требуется регулярное проведение лечебных процедур.

Критерии выписки

1. полный курс специфической терапии по стадии и форме сифилиса;
2. разрешение заразных проявлений.

При выявлении антител к ВИЧ пациента направляют в региональный центр по профилактике и борьбе со СПИДом; сифилис у ВИЧ-инфицированных лечат по тем же схемам. Нетрепонемные тесты у них часто остаются положительными после лечения.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Сифилис»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 09.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	197_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество дерматовенерологов и косметологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Вторичный сифилис: в рекомендации бензилпенициллина новокаиновая соль 600 тыс. ЕД 2 раза в сутки назначается на 20 дней, в комментарии к ней — на 28 дней.
- Ранний скрытый сифилис: в рекомендации бензилпенициллина натриевая соль 1 млн ЕД вводится каждые 6 часов, в комментарии — каждые 4 часа.

Клинические рекомендации

Сотрясение головного мозга

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S06.0** — Сотрясение головного мозга
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.01.2026, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/734_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Сотрясение головного мозга — наиболее лёгкая клиническая форма диффузного транзиторного повреждения мозга без видимых изменений на КТ; вместе с ушибом мозга лёгкой степени относится к лёгкой черепно-мозговой травме.
- **Оториноларингологу**
  1. признаки перелома основания черепа: кровоподтёки в области сосцевидного отростка, периорбитальные гематомы, истечение жидкости из наружных слуховых проходов, носа, рта;
  2. при жалобах или для объективизации диагноза показан осмотр оториноларинголога;
  3. при бессимптомном течении динамическое отоневрологическое исследование (аудиометрия, электронистагмография, электрогустометрия) выявляет симптомы раздражения вестибулярного анализатора без признаков выпадения.
- КТ головного мозга выполняется при наличии факторов риска: возраст **старше 60 лет**, рвота, судороги, антикоагулянтная терапия, снижение сознания по шкале комы Глазго, подозрение на перелом черепа, длительная посттравматическая амнезия.
- При установленном диагнозе допустимо амбулаторное лечение; строгий постельный режим не рекомендуется. В первые **48 часов** следует воздерживаться от использования экрана: это ускоряет регресс симптомов.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Лёгкая черепно-мозговая травма — остро развившееся нарушение функции мозга вследствие травматического воздействия, при котором может отмечаться кратковременная потеря сознания (**до 30 минут**) и/или амнезия (**до 24 часов**); включает сотрясение головного мозга и ушиб мозга лёгкой степени.

Сотрясение головного мозга — наиболее лёгкая клиническая форма диффузного транзиторного повреждения мозга, в основе которого лежат метаболические, ионные, нейротрансмиттерные нарушения и нейровоспаление; видимые изменения на КТ отсутствуют.

2.2 Этиология и эпидемиология

Сотрясение мозга обусловлено преимущественно инерционной травмой при определённых параметрах углового и трансляционного ускорения, но может возникать и при ударном ускорении. Ушиб мозга отличается от сотрясения макроструктурными повреждениями мозгового вещества.

Лёгкая черепно-мозговая травма составляет 60–95% всех случаев черепно-мозгового травматизма; соотношение сотрясения и ушиба лёгкой степени — примерно 4:1. Смертность при лёгкой травме низкая (0,04–0,29%) и практически исключительно вызвана внутричерепными гематомами.

2.3 Классификация

Клинические формы черепно-мозговой травмы

1. сотрясение мозга;
2. ушиб мозга лёгкой, средней и тяжёлой степени;
3. диффузное аксональное повреждение;
4. сдавление мозга;
5. сдавление головы.

Острый период при сотрясении мозга длится **до 2 недель**, промежуточный период при лёгкой травме — **до 2 месяцев**.

2.4 Клиническая картина

Сотрясение характеризуется нарушением сознания после травмы от нескольких секунд до нескольких минут и амнезией на короткий период (от нескольких минут **до 1 часа**); у 70% отмечается кратковременная утрата сознания в момент травмы.

Субъективные симптомы

1. головная боль (до 90%);
2. несистемное головокружение (около 70–75%);
3. тошнота, рвота, преимущественно однократная (около 35%);
4. общая слабость, быстрая утомляемость;
5. шум в ушах (10%), светобоязнь (10%);
6. вегетативные симптомы, нарушение сна, боли при движении глазных яблок, нарушение конвергенции.

Регресс симптоматики у подавляющего большинства пострадавших происходит в среднем за **4–5 суток**, временная нетрудоспособность обычно не превышает двух недель. При сохранении симптомов **более 7 суток** необходимы дополнительное обследование и выяснение причин.

У 5–50% пострадавших могут отмечаться более длительные физические, когнитивные, эмоциональные и поведенческие расстройства — персистирующий постконтузионный синдром.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: факт травмы с потерей или нарушением сознания со слов пострадавшего или очевидцев;
2. физикального обследования: раны и ссадины на голове, признаки перелома костей черепа;
3. тщательного неврологического осмотра при поступлении и в динамике;
4. КТ головного мозга по показаниям.

3.2 Жалобы и анамнез

Что уточнить

1. механизм травмы: ускорение-замедление, ударно-противоударный, минно-взрывной;
2. факт нарушения сознания и его длительность;
3. наличие посттравматической амнезии и её длительность.

Важной прогностической характеристикой является длительность посттравматической амнезии: при амнезии **менее 24 часов** хорошее восстановление отмечается у 100% пациентов.

3.3 Физикальное обследование

При осмотре головы выявляют

1. признаки перенесённой травмы: ушибы, ссадины, раны;
2. кровоподтёки в области сосцевидного отростка, периорбитальные гематомы;
3. истечение жидкости из наружных слуховых проходов, носа, рта — признаки перелома основания черепа.

Неврологический осмотр с оценкой по шкале комы Глазго проводится при поступлении и в динамике; показан осмотр нейрохирурга или невролога. Мелкоразмашистый нистагм, анизорефлексия, атаксия, лёгкие оболочечные симптомы исчезают у 90% пациентов **в течение 4–5 суток**.

3.4 Инструментальные исследования

Основные факторы риска — показания к КТ головного мозга

1. возраст **старше 60 лет**, рвота, посттравматические судороги, антикоагулянтная терапия;
2. менее 15 баллов по шкале комы Глазго или снижение **на 2 и более балла**;
3. подозрение на открытый или вдавленный перелом черепа, клинические признаки повреждения основания или свода черепа;
4. посттравматическая амнезия **более 4 часов**, опасный механизм травмы (ДТП).

Дополнительные факторы: возраст 40–60 лет, потеря сознания, персистирующая антероградная амнезия, амнезия 2–4 часа, очаговая неврологическая симптоматика. При невозможности КТ выполняют рентгенографию черепа и эхоэнцефалографию.

3.5 Консультации специалистов

При наличии жалоб или для объективизации диагноза показан осмотр офтальмолога, оториноларинголога, психиатра.

Отоневрологическое исследование при бессимптомном течении

1. аудиометрия;
2. электронистагмография;
3. электрогустометрия.

Оно выявляет симптомы раздражения вестибулярного анализатора при отсутствии признаков выпадения.

Исключительное значение для диагностики приобретает динамика признаков: их обычное исчезновение **через 3–5 суток** подтверждает диагноз сотрясения мозга.

---

4. Лечение

4.1 Режим и активность

Постельный режим с исключением всей внешней стимуляции на протяжении всего срока наблюдения не рекомендуется: он не улучшает восстановление. После начального периода покоя необходимо постепенное возвращение к повседневной активности; деятельность с риском повторной травмы мозга исключают до полного клинического восстановления.

Рекомендуется отказ от деятельности, требующей внимания и концентрации, в частности от использования экрана **в течение первых 48 часов**: регресс симптомов ускоряется с 8 **до 3,5 суток**. Противоэпилептические препараты с профилактической целью не рекомендуются.

4.2 Головная боль и нарушения сна

В первую очередь — немедикаментозное лечение головной боли

1. нормализация сна;
2. регулярное питание и достаточный питьевой режим;
3. исключение стрессовых факторов;
4. умеренная физическая нагрузка.

При головной боли напряжения назначают анальгетики, кроме опиоидов, при неэффективности — комбинированные анальгетики.

При нарушениях сна назначают мелатонин 2 мг в сутки (возможно 3 мг); производные бензодиазепина не рекомендуются.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Показано наблюдение невролога с оценкой общего состояния, неврологического и психического статуса **через 1, 3 и 6 месяцев**. Клинически значимые отдалённые последствия к году после травмы наблюдаются примерно в 10–15% случаев.

5.2 Показания к госпитализации

Амбулаторное лечение под наблюдением невролога проводится при условии выполнения КТ головного мозга или отсутствия показаний к ней.

Показания к госпитализации

1. ушибленные раны головы с кровопотерей;
2. выраженная общемозговая симптоматика.

Госпитализация — в нейрохирургическое отделение, при его отсутствии — в травматологическое или неврологическое. Критерий выписки — клиническое улучшение.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Сотрясение головного мозга»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 15.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	734_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.

Клинические рекомендации

Травма гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**R04.1** — Кровотечение из горла **S10.0** — Ушиб горла **S10.1** — Другие и неуточненные поверхностные травмы горла **S11.0** — Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 19.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/813_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Травма гортани опасна для жизни. Главным является проходимость дыхательных путей: дыхательная недостаточность может нарасти позже из-за отёка и гематомы. Госпитализации для наблюдения подлежат все пострадавшие, при лёгкой травме на **24–48 часов**, особенно дети.
- При значительном или нарастающем отёке гортани показана трахеотомия в сознании. Интубации по возможности избегают, поскольку трубка может усугубить повреждение. При интубации используют трубку на размер меньше расчётной и сохраняют иммобилизацию шейного отдела позвоночника.
- Обследование при поступлении:
  1. ларингоскопия и видеоларингоскопия всем пациентам;
  2. пальпация шеи и грудной клетки для исключения подкожной эмфиземы;
  3. при подозрении на повреждение сосудов: КТ шеи с внутривенным контрастированием;
  4. при подозрении на повреждение глотки и пищевода: КТ пищевода с пероральным контрастированием;
  5. исключение повреждения шейного отдела позвоночника.

  МРТ при осколочных и пулевых ранениях не рекомендуется.
- Лечение консервативное при травме без повреждения хрящей или без смещения отломков, без нарастания дыхательной недостаточности и без гнойно-воспалительных изменений в тканях шеи:
  1. противоотёчная терапия;
  2. при признаках стеноза: ингаляции будесонида и кислород;
  3. голосовой покой;
  4. антирефлюксные препараты;
  5. при открытой ране: антибактериальная терапия и профилактика столбняка.
- Показания к хирургическому лечению:
  1. стеноз гортани в стадии декомпенсации;
  2. кровотечение;
  3. открытая или загрязнённая рана, инородные тела, нежизнеспособные ткани;
  4. выраженная или нарастающая эмфизема;
  5. перелом хрящей гортани со смещением, суживающим просвет.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. открытая рана, затрагивающая гортань: повреждение гортани снаружи или изнутри с нарушением целостности кожи и слизистой, целостности и функции органа;
2. ушиб глотки, гортани: закрытое повреждение тупым предметом без нарушения целостности кожи и слизистой, с разрывом мелких сосудов и кровоизлиянием.

Кровотечение из горла: истечение крови изо рта или попадание её в дыхательные или пищепроводящие пути из источника в ротоглотке, гортаноглотке или гортани.

2.2 Этиология

Причины травмы гортани зависят от её вида.

1. открытые раны чаще всего бывают ножевыми и огнестрельными;
2. наружные тупые травмы возникают при ударе тупым предметом или кулаком в шею, в автомобильной аварии, при спортивной травме, попытке удушения и зачастую сопровождаются переломом хрящей и подъязычной кости, отрывом гортани, разрывом голосовых складок;
3. внутренняя травма с кровотечением чаще носит ятрогенный характер (интубация, ИВЛ) или вызвана инородным телом (рыбья кость, куски пищи, зубные протезы);
4. кровотечение из горла могут вызывать также злокачественные опухоли, последствия операций и манипуляций в глотке и гортани, в том числе эндоскопических исследований.

Возможные повреждения

1. перелом подъязычной кости, хрящей гортани и трахеи;
2. отрыв гортани от трахеи или подъязычной кости;
3. разрыв голосовых складок, смещение черпаловидных хрящей, парез гортани;
4. кровоизлияния и гематомы со сдавлением дыхательных путей.

У детей гортань из гибких хрящей, устойчива к перелому, но подслизистый слой слабо прикреплён к надхрящнице: выше риск массивного отёка и гематомы, даже малая травма может повредить слизистую и заднюю стенку трахеи.

2.3 Классификация

1. по этиологии: механические (в том числе ятрогенные), огнестрельные, химические, термические;
2. по механизму: наружные, внутренние, тупые, острые (колотые, резаные);
3. по кожной ране: открытые, закрытые;
4. по проникновению в полость гортани: проникающие, непроникающие;
5. изолированные и сочетанные.

Тяжесть травмы гортани по Schaefer

Группа	Повреждения
1	незначительные эндоларингеальные гематомы без повреждения слизистой и хрящей
2	отёк, гематома, незначительные повреждения слизистой без обнажения хряща или перелом хряща без смещения
3	массивный отёк, большие разрывы слизистой, обнажённый хрящ, перелом хряща со смещением или неподвижность голосовых складок
4	как в 3 группе плюс серьёзные повреждения передних отделов, нестабильные переломы, две и более линии перелома или тяжёлые травмы слизистой
5	полный отрыв гортани от трахеи

Огнестрельные ранения гортани: касательные без проникновения в полость; проникающие слепые или сквозные без повреждения окружающих структур; проникающие с повреждением пищевода, сосудисто-нервного пучка, позвоночника. Травмы глотки делят на наружные и внутренние, по причине, повреждающему фактору (тупые, колото-резаные, огнестрельные, химические и термические ожоги, инородные тела), отделу глотки и распространённости.

2.4 Клиническая картина

Симптомы

1. нарушение дыхания является главным симптомом и может развиться сразу после травмы или позже из-за нарастания воспалительной инфильтрации, отёка, гематомы;
2. дисфония и афония возникают при всех травмах гортани и особенно выражены при повреждении голосового отдела;
3. боль бывает различной интенсивности: от дискомфорта (ощущения инородного тела) до выраженной боли в проекции гортани и глотки;
4. дисфагия возникает при повреждении входа в гортань, парезе гортани, патологии глотки;
5. кашель сопровождает травму не всегда: как правило, он возникает при инородном теле в гортани, внутреннем кровотечении, остром воспалении;
6. подкожная эмфизема шеи свидетельствует о проникающем повреждении гортани или трахеи и может быстро распространиться на грудь и средостение;
7. кровотечение угрожает жизни при открытой травме крупных сосудов, а также при внутреннем кровотечении, вызывающем аспирацию крови или гематому, суживающую просвет гортани и трахеи;
8. проникающая рана имеет характерный вид: на выдохе из неё выходит пузырящийся кровавой пеной воздух, на вдохе воздух засасывается в рану с шипением;
9. внутренняя травма может сопровождаться кровотечением из горла, которое проявляется кровохарканьем и истечением крови изо рта;
10. при повреждении гортанных нервов развивается парез гортани.

Внутренние повреждения глотки, как правило, протекают легче наружных. Пациент обычно указывает место повреждения и предшествовавшие обстоятельства (эндоскопическое вмешательство, приём пищи, интубация).

Сразу после травмы

1. боль в горле, усиливающаяся при глотании;
2. нарушение глотания;
3. при разрыве слизистой оболочки возможно кровотечение;
4. при нарастании отёка возможно нарушение дыхания.

У детей дыхательные нарушения развиваются быстрее и тяжелее; тупая травма гортани и трахеи может протекать неявно и имитировать обычные респираторные болезни.

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. анамнез, не позволяющий исключить травму шеи, и появление после неё боли, затруднения дыхания, изменения голоса, затруднения глотания, кровотечения, одышки;
2. инспираторный стридор указывает на обструкцию надскладкового отдела гортани, вызванную отёком или гематомой;
3. экспираторный стридор, как правило, возникает при обструкции подскладкового отдела гортани, например при травме трахеи;
4. двухфазный стридор указывает на повреждение голосовой щели;
5. рана либо отёк и гематома шеи, подкожная эмфизема;
6. исчезновение крепитации гортани: при смещении гортани в стороны обычно ощущается «щелчок», его исчезновение возможно при фиксации или повреждении гортани;
7. на выдохе из раны пузырящаяся кровавая пена, кровь в слюне;
8. видеоларингоскопия: отёк, кровоизлияние, гематома, разрыв слизистой, деформация голосовой щели, нарушение подвижности складок;
9. КТ: деформация контуров шеи, эмфизема, перелом хрящей, изменения просвета, раневой канал, инородные тела, нарушение пассажа контраста при ранении глотки и пищевода.

Выясняют механизм травмы, время после неё, жалобы и их динамику; если пациент без сознания, сведения получают у родственников или сопровождающих. Первичную оценку проводят по принципам расширенного жизнеобеспечения при травме (ATLS).

3.1 Осмотр раны и пальпация шеи

Всем пациентам оценивают рану: локализацию, размеры, глубину, края, отношение к сосудам и нервам. Исключают инородные тела, наружное или горловое кровотечение, повреждение дыхательных путей.

Пальпация шеи и грудной клетки всем пациентам для исключения подкожной эмфиземы.

3.2 Ларингоскопия

Выполняется всем пациентам при поступлении в стационар.

Непрямая ларингоскопия зеркалом обязательна пациентам **12 лет и старше**; у дошкольников и младших школьников часто невозможна из-за эмоциональной лабильности и глоточного рефлекса.

3.3 Видеоларингоскопия и микроларингоскопия

Всем пациентам: гибкие и ригидные эндоскопы с углом обзора 70° и 90°.

Оценивают слизистую, отёк, голосовую щель и подвижность складок, подскладковый отдел и трахею; при ране — возможен ретроградный осмотр. У детей предпочтительна фиброларингоскопия.

Показания

1. 2–5 группы тяжести по Schaefer: уточнение диагноза, выбор метода и объёма лечения.

После обеспечения стойкой проходимости дыхательных путей: перстнечерпаловидное сочленение, слизистая, хрящевой каркас.

3.4 Ларингостробоскопия и электромиография гортани

При наличии оборудования исследования показаны всем пациентам для объективной оценки подвижности голосовых складок.

3.5 УЗИ гортани у детей

Показания

1. дети с травмой гортани: УЗИ гортани в дополнение к ларингоскопии.

Видны подвижность складок и черпаловидных хрящей, их асимметрия, утолщение складок, переломы щитовидного хряща, гематомы.

3.6 КТ шеи и пищевода

Показания

1. подозрение на повреждение сосудов: КТ шеи, в том числе с внутривенным контрастированием.

Рентгенография мягких тканей шеи малоинформативна: видны только отёк, эмфизема, перелом подъязычной кости.

КТ показывает

1. хрящевой каркас гортани и подъязычную кость;
2. раневой канал и инородные тела;
3. вовлечение сосудов шеи;
4. распространённость эмфиземы.

Показания

1. подозрение на повреждение глотки, пищевода: КТ пищевода с пероральным контрастированием при поступлении.

3.7 Эзофагоскопия

Показания

1. проникающее ранение гортани или глотки: эзофагоскопия для исключения повреждения пищевода.

3.8 Исследование шейного отдела позвоночника

При любой травме гортани исключают повреждение шейного отдела позвоночника; при его выявлении показана немедленная консультация профильного специалиста.

3.9 МРТ

МРТ при осколочных и пулевых ранениях не рекомендуется: металлические инородные тела могут сместиться.

3.10 Общий анализ крови и коагулограмма

Показания

1. кровопотеря или подозрение на неё: общий анализ крови;
2. все пациенты: коагулограмма.

3.11 Пульсоксиметрия

Детям с признаками стеноза показана пульсоксиметрия для оценки степени дыхательной недостаточности и необходимости кислорода.

3.12 Посев отделяемого раны

При ранении гортани или глотки выполняют посев отделяемого раны с определением чувствительности к антибиотикам.

4. Лечение

Принципы при любой тактике

1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей;
2. остановка кровотечения, восполнение кровопотери;
3. профилактика травматического шока;
4. противоотёчная, антибактериальная, дезинтоксикационная, противовоспалительная терапия.

Первоочередное внимание следует уделять проходимости дыхательных путей: необходимо своевременно распознать обструкцию или угрозу её развития и предотвратить аспирацию.

Лечебная тактика по группам тяжести Schaefer

Группа	Тактика
1 группа	обязательна гибкая эндоскопия гортани; как правило, медикаментозно, без операции: системные кортикостероиды, антибиотики, антирефлюксные, увлажнение воздуха, голосовой покой
2 группа	дополнительно прямая ларингоскопия и эзофагоскопия; наблюдение в динамике, повреждения могут прогрессировать; иногда трахеотомия; та же медикаментозная терапия
3 группа	прямая ларингоскопия или эзофагоскопия в операционной; часто трахеотомия, как правило, операция при разрыве передней комиссуры, обширных рваных ранах, разрывах и неподвижности складок, обнажении хряща, переломах со смещением, подвывихе черпаловидного хряща
4 группа	обязательны прямая ларингоскопия и эзофагоскопия; всегда трахеотомия; при операции — стент
5 группа	тяжёлая дыхательная недостаточность: эндоскопия откладывается до восстановления проходимости; повреждения на уровне перстневидного хряща, перстнещитовидной мембраны, перстнетрахеального соединения: трахеотомия (может быть сложной), ларинготрахеопластика

> В КР тактика описана для групп «1, 2, 2, 3, 4»: в таблице группы 3–5 подписаны по смыслу описания (в КР это «2», «3» и «4»).

4.1 Консервативное лечение

Показания

1. ссадины и поверхностные повреждения кожи;
2. тупые наружные и внутренние травмы с отёком, ссадинами, гематомами без повреждения хрящей или без смещения отломков;
3. нет нарастания дыхательной недостаточности и гнойного воспаления в тканях шеи.

Ссадины обрабатывают антисептиком и закрывают асептической повязкой; при стабильном состоянии — симптоматическая терапия.

При инфицированной ране или высоком риске инфицирования у взрослых и детей применяют антисептики до разрешения инфекции или эпителизации

1. бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний;
2. повидон-йод;
3. хлоргексидин.

Показания

1. признаки стеноза верхних дыхательных путей: ингаляции лекарственных препаратов и кислорода.

После травмы и при эвакуации подают прохладный кислород через маску.

Будесонид ингаляционно

1. взрослые: раствор 1,0 мг 1–2 раза в день, 5–8 процедур;
2. дети **старше 6 месяцев**: суспензия 0,25–0,5 мг 1–2 раза в день, 5 процедур.

Ингаляция длится, как правило, 10 минут, интервал между ингаляциями разных препаратов около 30 минут.

При открытой и закрытой травме проводится противоотёчная терапия: парентерально системные кортикостероиды и диуретики.

Голосовой режим: не кричать и не шептать **не менее 2 дней**; полный голосовой покой **1–2 суток**, затем ограничение нагрузки. Исключить острую, солёную, горячую, холодную пищу, алкоголь, курение.

При ране или воспалении слизистой оболочки гортани и гортаноглотки назначают препараты для лечения язвенной болезни и ГЭРБ (A02BX) для защиты от желудочного содержимого.

4.2 Обезболивание

Всем пострадавшим: анальгетики и НПВП, отдельно или в комбинации, в том числе НПВП с парацетамолом, метамизол натрия; также после операции.

Ограничения у детей

1. ибупрофен: с 3 месяцев свечи и суспензия, с 6 лет таблетки, с 12 лет капсулы;
2. кетопрофен: с 6 лет гранулы, с 15 лет парентерально;
3. метамизол натрия: амбулаторно не применяется, в стационаре только при отсутствии других разрешённых детям анальгетиков.

Хирургическую обработку и манипуляции в гортани выполняют под местной анестезией с учётом раны, выраженности боли и аллергологического анамнеза.

Обезболивание у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	1 г в/в инфузия 15 мин	4 ч	4 г	5–7 сут
Диклофенак	75 мг в/м (в КР «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 сут
Кеторолак	30 мг в/в, в/м	6 ч	60–90 мг	2 сут
Кетопрофен	100 мг в/в, в/м	12 ч	200 мг	не более 2 сут
Лорноксикам	8 мг в/в, в/м	12 ч	16 мг	1–7 сут
Дексketопрофен	50 мг в/в, в/м	8–12 ч	150 мг	2 сут
Метамизол натрия	500–1000 мг в/в, в/м	8–12 ч	2 г	1–5 сут

Обезболивание у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол в/в	инфузия 15 мин: более 50 кг — 1000 мг; 10–50 кг — 15 мг/кг; менее 10 кг — 7,5 мг/кг; новорождённым до 1 месяца противопоказан	4 ч	более 50 кг — 4 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, не более 3 г; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, не более 2 г; менее 10 кг — менее 30 мг/кг	5–7 сут
Парацетамол внутрь, суспензия	10–15 мг/кг	6 ч	не более 60 мг/кг	3–5 сут
Парацетамол ректально	10–14 лет 350–500 мг; 5–10 лет 250–350 мг; 3–5 лет 150–200 мг; 1–3 года 100–150 мг; 3–12 мес 50–100 мг	4–6 ч	менее 60 мг/кг	до 5 сут
Ибупрофен внутрь	старше 6 лет 200–400 мг; 4–6 лет 150 мг; 1–3 года 100 мг; 6–12 мес 50 мг; 3–6 мес 50 мг	8 ч; 6–8 ч (в таблице КР не сопоставлены с возрастами построчно)	12–17 лет 1 г; 6–12 лет 800 мг; 4–6 лет 450 мг; 1–3 года 300 мг; 6–12 мес 200 мг; 3–6 мес 150 мг	4 сут
Ибупрофен ректально	3–9 мес 60 мг; 9–24 мес 60 мг	3–9 мес 8 ч; 9–24 мес 6 ч	3–9 мес 180 мг; 9–24 мес 240 мг	не более 3 сут
Кетопрофен в/в, в/м	с 15 лет 100 мг	12 ч	200 мг	не более 2 сут
Кетопрофен внутрь, гранулы	старше 6 лет 40 мг	8 ч	120 мг	не более 2 сут
Метамизол натрия	с 15 лет 500–1000 мг в/в, в/м; 3 мес – 1 год 50–100 мг/10 кг в/м	8–12 ч	с 15 лет 2 г	3 сут

4.3 Антибактериальная терапия

Показания

1. открытая рана, осложнения, сочетанные повреждения: системная антибактериальная терапия (близость ротоглотки повышает риск инфекции).

Цефалоспорины III поколения (цефотаксим или цефтриаксон) и инфузионно метронидазол; при распространении эмфиземы в средостение и риске медиастинита — меропенем. Доза и длительность определяются клинической ситуацией.

Антибиотики при травмах шеи

Препарат	Разовая доза	Кратность	Длительность
Цефотаксим в/в, в/м	взрослые и дети старше 12 лет (более 50 кг): 1 г; дети до 12 лет (менее 50 кг): 50–75 мг/кг; новорождённые: 25 мг/кг	2 раза в сутки	7–10 дней
Цефтриаксон в/в, в/м	взрослые 1–2 г; дети 2 мес – 12 лет: 20–100 мг/кг; новорождённые (с 15 дней), грудные и младшего возраста: 20–80 мг/кг	1 раз в сутки	7–10 дней
Метронидазол в/в капельно, 5 мл/мин	старше 12 лет: 500 мг; до 12 лет: 7,5 мг/кг	3 раза в сутки	7–10 дней

4.4 Профилактика столбняка

При повреждении кожи и слизистой оболочки с загрязнением раны экстренная профилактика столбняка проводится как можно раньше, **до 20-го дня** после травмы: столбнячный анатоксин, противостолбнячный иммуноглобулин человека или сыворотка по инструкции.

4.5 Гемостатическая терапия

Показания

1. наружное кровотечение или кровотечение из горла: гемостатические средства; при небольшом наружном кровотечении достаточно давящей асептической повязки.

Дозы

1. этамзилат: взрослым 250–500 мг в/в или в/м, затем по 250 мг каждые 4–6 ч; детям 10–15 мг/кг в сутки в 3–4 приёма, 5–10 дней;
2. транексамовая кислота: в/в медленно 1 мл/мин (50 мг/мин); взрослым 10–15 мг/кг каждые 6–8 ч, детям старше 1 года 20 мг/кг в сутки — до остановки кровотечения;
3. аминокапроновая кислота в/в капельно, взрослые: 4–5 г за первый час, при продолжающемся кровотечении по 1 г/ч не более 8 ч, при необходимости инфузии повторяют каждые 4 часа, максимум 30 г в сутки;
4. аминокапроновая кислота, дети: 100 мг/кг за первый час, затем 33 мг/кг/ч; максимальная суточная доза 18 г/м^2: до 1 года 3 г, 2–6 лет 3–6 г, 7–10 лет 6–9 г, от 10 лет как взрослым;
5. аминокапроновая кислота при острой кровопотере у детей: до 1 года 6 г, 2–4 лет 6–9 г, 5–8 лет 9–12 г, 9–10 лет 18 г;
6. длительность терапии аминокапроновой кислотой: 3–14 дней.

4.6 Хирургическое лечение

Показания

1. стеноз гортани в стадии декомпенсации;
2. кровотечение;
3. открытая, загрязнённая рана, инородные тела, нежизнеспособные ткани, потеря мягких тканей, дефицит кожи;
4. выраженная или нарастающая эмфизема;
5. перелом хрящей гортани со смещением, суживающим просвет.

Показания

1. значительный, особенно нарастающий отёк гортани: трахеотомия в сознании.

На месте травмы допустимо ввести трубку через рану в гортань или трахею, выполнить коникотомию или крикотиреоидотомию с последующей заменой на типичную трахеостому с подшиванием трахеи к коже. По возможности избегают интубации. Детям трахеотомию выполняют только под комбинированным ингаляционным наркозом.

При тяжёлых ранениях шеи применяют тактику контроля повреждений (damage control surgery): сокращённая первая операция, окончательное восстановление после стабилизации.

Первый этап

1. устранение асфиксии: интубация, типичная или атипичная трахеотомия;
2. остановка кровотечения: сосудистый шов, перевязка, тугая тампонада, временное протезирование сонных артерий;
3. защита тканей шеи от содержимого полых органов: швы или мазевые тампоны;
4. иммобилизация шеи воротником Шанца при ранении позвоночника.

Интубационную трубку берут на размер меньше расчётной, сохраняя иммобилизацию шейного отдела.

Показания

1. кровотечение из горла: тампонада раны, коагуляция сосуда, сшивание раны;
2. массивное некупируемое: эндоваскулярная окклюзия или перевязка наружной сонной артерии;
3. обширное повреждение гортани с неясным источником: перевязка верхней щитовидной или наружной сонной артерии после трахеотомии ниже места повреждения.

Кровотечение останавливают экстренно для профилактики геморрагического шока: давящая повязка и гемостатики, при неэффективности — лигатуры на сосуд в ране.

4.7 Хирургическая обработка раны

Объём по типу раны

1. поверхностная: обработка, санация, первичный шов;
2. глубокая с повреждением мягких тканей: рассечение, иссечение, восстановление структур, дренирование, шов, противовоспалительная и антибактериальная терапия;
3. обширные скальпированные и размозжённые: первичная обработка, первичная или отсроченная пластика кожи, восстановление структур, дренирование, по показаниям трансфузия.

Обработка ран гортани должна быть экономной и ранней: удаляют только легкодоступные инородные тела и явно нежизнеспособные ткани, слизистую оболочку максимально сохраняют. Раны гортани и трахеи **до 0,5 см** можно не ушивать и лечить дренированием.

Первичную хирургическую обработку не проводят

1. поверхностные раны, царапины, ссадины;
2. раны с расхождением краёв **менее 1 см**;
3. множественные мелкие раны без повреждения мышц и фасций;
4. колотые раны без повреждения органов, сосудов, нервов.

Туалет раны, края можно свести пластырем.

Все раны дренируют доступными способами до прекращения отделяемого.

При инфицировании раны и гнойных осложнениях рану не ушивают до их купирования.

4.8 Переломы и разрывы гортани

Любые переломы хрящей гортани со смещением фиксируют. Сроки дискутабельны: одни авторы оперируют в первые **24–48 часов**, другие откладывают операцию на неделю и более до уменьшения отёка, поэтому срок определяют индивидуально.

Показания

1. разрыв слизистой двух и более анатомических областей, свободного края голосовых складок, переломы хрящевого каркаса: тиреоидотомия.

Слизистую восстанавливают, раны складок ушивают рассасывающимся швом 5/0 или 6/0; открытые хрящи закрывают. При переломе **более чем в 3 мм** от передней комиссуры также выполняется срединная тиреоидотомия.

Смещённые черпаловидные хрящи восстанавливают по степени повреждения; изолированные рваные раны укрывают слизистой.

Проникающее ранение с повреждением хрящей без значительного смещения: ларинготрахеопластика местными тканями после типичной трахеотомии; при необходимости наружный и эндоскопический доступ, в просвет на несколько дней вводят пальчиковый обтуратор.

Показания к формированию ларинготрахеостомы при проникающем ранении гортани после ревизии раны

1. значительное разрушение и смещение хрящей;
2. разрывы тканей в области передней комиссуры;
3. выраженная рубцовая деформация просвета гортани.

В первые дни вводят тампон по Микуличу с мазью на основе хлорамфеникола, затем силиконовый протез. Оскольчатые переломы часто требуют стента и наружной фиксации; при стабильных переломах с минимальным повреждением слизистой стентирования избегают.

Перелом подъязычной кости с отрывом гортани: ларингогиоидопексия; отрыв гортани от трахеи: трахеоларингопексия (при низком трахеотомическом разрезе трахея втягивается за грудину). Отрыв гортани, как правило, сопровождается пневмотораксом, который необходимо выявить и лечить.

4.9 Диетотерапия

Общая восстановительная диета, полноценная по составу, кроме пациентов с заболеваниями, требующими коррекции диеты (сахарный диабет и другие). Пациентам с зондом или гастростомой проводится энтеральное или парентеральное питание.

Назогастральный зонд и парентеральное питание показаны при

1. ранении гортаноглотки, пищевода;
2. выраженном отёке гортаноглотки;
3. невозможности питания через естественные пути.

---

5. Медицинская реабилитация и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализации для наблюдения за проходимостью дыхательных путей подлежат все пациенты с травмой гортани и глотки. При лёгких травмах, которые могут прогрессировать (отёк, гематома), наблюдение в стационаре длится **24–48 часов**, особенно у детей.

У детей травма гортани опасна для жизни риском кардиогенного шока из-за особенностей иннервации вследствие

1. брадикардии, аритмии;
2. падения артериального давления;
3. остановки сердца.

Небольшие непрогрессирующие гематомы при целой слизистой оболочке, как правило, рассасываются, большие или нарастающие могут потребовать трахеотомии.

Все, кто оказывает помощь на догоспитальном и госпитальном этапах, должны знать признаки обструкции дыхательных путей и владеть навыками поддержания дыхания с защитой шейного отдела позвоночника; на всех уровнях должны быть возможности интубации, коникотомии, трахеотомии.

5.2 Медицинская реабилитация и диспансерное наблюдение

После тупой травмы с повреждением гортани, а также после ларинготрахеопластики без ларингостомы или после её закрытия показан повторный осмотр оториноларинголога в поликлинике, при нарушении голоса консультация фониатра.

Пациентов с открытой раной шеи и сформированной ларингостомой наблюдает оториноларинголог стационара.

После выписки лечение продолжается амбулаторно под наблюдением оториноларинголога.

Повторный осмотр оториноларинголога **через 1 месяц**, затем **раз в 3 месяца** в течение года для выявления показаний к реконструктивной операции.

При осмотре выполняют

1. видеоларингоскопию;
2. ларингостробоскопию;
3. по показаниям исследование функции внешнего дыхания.

Сроки деканюляции и восстановления просвета определяют индивидуально.

Для профилактики ятрогенной травмы при ИВЛ, ЭГДС, бронхоскопии интубацию и эндоскопию выполняют максимально аккуратно, при трудной интубации используют видеоларингоскоп. Специфической профилактики других травм гортани и глотки нет.

Факторы неблагоприятного исхода операции

1. системные: пожилой возраст, иммунодефицит, кахексия, инфекция, онкологический процесс, нарушения углеводного обмена, коллагенозы;
2. местные: повреждение пищевода, сосудисто-нервного пучка, позвоночника, флегмона шеи, медиастинит, повторная травма, инфекция, инородные тела.

При первичной пластике и восстановлении просвета грубой деформации, как правило, нет, но травмы гортани и трахеи часто инвалидизируют и могут потребовать повторных реконструктивных операций.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма гортани»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 19.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	`813_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 3 тактика по тяжести травмы описана для групп «1, 2, 2, 3, 4», а классификация Schaefer в разделе 1.5 содержит 5 групп: нумерация в лечебном разделе сдвинута. На странице группы подписаны по смыслу описания, с пометкой под таблицей.
- Таблица 1: разовая доза диклофенака записана как «75 мл в/м» — по смыслу 75 мг.
- Таблица 2: для парацетамола внутривенно у детей максимальные суточные дозы заданы для пересекающихся весовых групп «33–50 кг» и «10–50 кг» с разными пределами (3 г и 2 г). Сверяйте с инструкцией.

Клинические рекомендации

Травма носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S00.3** — Поверхностная травма носа **S01.2** — Открытая рана носа **S02.2** — Перелом костей носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/815_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Для выявления перелома костей носа взрослым и детям **с 3 лет** выполняют рентгенографию костей лицевого скелета в боковой проекции. Чувствительность метода не превышает 70%, поэтому отсутствие изменений на рентгенограмме не исключает перелома.
- При гематоме или абсцессе перегородки носа показаны вскрытие и дренирование с последующей передней тампонадой и ежедневными перевязками до прекращения отделяемого.
- При травматической деформации носа показаны репозиция костей и фиксация отломков:
  1. ранняя операция **в первые 7 суток**;
  2. при тяжёлом состоянии или выраженном отёке вмешательство может быть отложено **до 15 суток**.
- При изолированном переломе, в том числе открытом, рутинное назначение системных антибиотиков не показано. Показания к антибактериальной терапии:
  1. загрязнённые и гнойные раны;
  2. выраженный отёчно-токсический синдром;
  3. осложнённая гематома или абсцесс перегородки носа;
  4. сочетанная и комбинированная травма;
  5. тяжёлая сопутствующая патология.
- При повреждении кожи или слизистой оболочки и загрязнении раны землёй необходима экстренная профилактика столбняка в максимально ранние сроки, но **не позднее 20-го дня** после травмы.
- Показания к госпитализации:
  1. тяжёлое состояние;
  2. выраженный отёк;
  3. кровотечение;
  4. выраженный болевой синдром;
  5. комбинированные переломы костей и перегородки носа с повреждением околоносовых пазух и ранениями лица;
  6. травматическая деформация носа со смещением перегородки или нарушением дыхания;
  7. тяжёлая сопутствующая патология;
  8. приём антикоагулянтов или антиагрегантов;
  9. осложнения: гематома и абсцесс перегородки носа, воспаление околоносовых пазух и соседних областей;
  10. необходимость закрытой репозиции.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Травма носа представляет собой повреждение носа в результате прямого или опосредованного воздействия травмирующего фактора снаружи или изнутри, сопровождающееся нарушением целостности тканей и структур наружного носа и полости носа и нарушением функций носа.

Поверхностной называется травма наружного носа без повреждения кожи, костей носа и слизистой оболочки полости носа и без неврологической симптоматики.

Ушиб носа является закрытым повреждением тупым предметом без видимого нарушения целостности кожи и слизистых оболочек, с разрывом мелких сосудов и кровоизлиянием. При кровоподтёке кровь пропитывает мягкие ткани наружного носа, тогда как гематома представляет собой скопление крови в ограниченной полости. Ссадиной называется повреждение поверхностного слоя кожи с визуально определяемым местом размозжения кожных сосудов.

Перелом костей носа (ПКН) характеризуется частичным или полным нарушением целостности носовых костей, лобных отростков верхней челюсти, перегородки носа или носовой ости. Перелом считается закрытым при сохранённой целостности кожи носа и открытым, если отломки сообщаются с внешней средой через рану.

Раной носа называется повреждение кожи наружного носа на всю глубину, часто с обнажением хрящей и костей и более глубоких структур полости носа, в ряде случаев с отрывом крыла или кончика носа.

2.2 Механизм травмы

При ударе во фронтальной плоскости возникает перелом носовых костей с западением спинки носа. Боковой удар может приводить к разъединению носовой кости и лобного отростка верхней челюсти с формированием сколиоза наружного носа, однако чаще линия перелома проходит выше шва между ними. Как правило, одновременно возникает перелом перегородки носа, чаще её хрящевого отдела.

У детей младшего возраста кости наружного носа эластичны, поэтому переломы встречаются редко, а гематома и абсцесс перегородки носа чаще.

При переломе нередко происходит разрыв и отслойка надхрящницы или надкостницы перегородки, кровь скапливается между хрящом и надхрящницей, и формируется гематома перегородки носа. При её инфицировании развивается абсцесс, четырёхугольный хрящ расплавляется, что приводит к деформации носа и нарушению его функций.

Травма носа может быть изолированной или сочетаться с повреждением околоносовых пазух, глаза, скуловой области, нижней челюсти, полости рта, ушной раковины, сотрясением или ушибом головного мозга.

2.3 Классификация

Общепринятая классификация переломов отсутствует. Согласно классификации Ю. Н. Волкова (1958), выделяют открытые и закрытые переломы, переломы без деформации и с деформацией наружного носа.

Согласно классификации С. Б. Бесшапочного (1984), переломы подразделяются на переломы без деформации и с деформацией наружного носа; последние могут быть одно- и двусторонними, с боковым смещением отломков, со смещением кзади или с сочетанием обоих видов смещения.

Согласно классификации А. С. Лопатина (2019), выделяют изолированные и сочетанные, открытые и закрытые переломы; переломы со смещением подразделяются по направлению удара на латеральные, фронтальные, фронтолатеральные и базальные.

По распространённости

1. изолированные: с деформацией наружного носа или без неё;
2. комбинированные: с травмой кожи лица, внутриносовых структур или околоносовых пазух;
3. сочетанные: с челюстно-лицевой или черепно-мозговой травмой, травмой конечностей, туловища и внутренних органов.

Стадии перелома со смещением

1. острая стадия: **первые 14 дней**; кости репонируют по стандартной методике;
2. застарелый перелом: **от двух недель до двух месяцев**; репозиция возможна только в сочетании с операцией на перегородке носа;
3. стойкая деформация: давность травмы **более двух месяцев**; сопоставление отломков возможно только после остеотомии.

2.4 Клиническая картина

Поверхностная травма характеризуется слабо выраженными проявлениями: в месте удара отмечаются боль, небольшая припухлость и умеренная гиперемия кожи без нарушения её целостности.

Признаки по видам травмы

1. ушиб: пирамида носа увеличена в объёме, контуры сглажены за счёт отёка;
2. кровоподтёк и ссадина: изменены цвет и целостность кожи;
3. перелом: пирамида носа смещена в сторону или вдавлена;
4. гематома: перегородка носа утолщена, носовые ходы сужены.

Возможны также

1. носовое кровотечение;
2. боль и болезненность при пальпации;
3. нарушение дыхания и обоняния.

При сочетанной травме

1. отёки, кровоподтёки, гематомы и раны других областей;
2. нарушения зрения и сознания.

Признаки перелома

1. отёк;
2. боль;
3. деформация наружного носа;
4. крепитация и подвижность отломков;
5. носовое кровотечение;
6. затруднение носового дыхания.

У детей с переломом деформация носа вследствие выраженного отёка определяется лишь в 57,5% случаев. Кроме того, у 7,4% детей деформация имелась до травмы.

При переломе нередко повреждены кожа носа и слизистая оболочка полости носа, возможны эмфизема мягких тканей носа и лица, экхимозы. Носовое кровотечение встречается часто, однако при неосложнённом изолированном переломе обильное и рецидивирующее кровотечение отмечается редко.

Перелом часто сопровождается кровоизлиянием в веки и мягкие ткани орбиты («симптом очков»), однако этот же симптом наблюдается при переломе переднего основания черепа и травме кавернозного синуса.

Крепитация и подвижность отломков выявляются менее чем в половине случаев, поэтому их отсутствие не исключает перелома. Болевой синдром в области носа также неспецифичен и встречается при ушибах и воспалительных заболеваниях носа.

2.5 Жалобы и анамнез

Необходимо выяснить

1. обстоятельства и механизм травмы, направление удара;
2. потерю сознания;
3. перенесённые ранее травмы носа с деформацией и операции на носу;
4. прививочный анамнез в отношении столбняка при комбинированной травме с повреждением кожи.

При общем осмотре оценивают артериальное давление, пульс и частоту дыхания.

---

3. Диагностика

Основания для диагноза

1. факт травмы со слов пострадавшего или очевидцев;
2. жалобы на боль, изменение формы носа, затруднение дыхания, кровотечение, нарушение обоняния;
3. данные осмотра: повреждения кожи, деформация, крепитация и подвижность отломков, кровотечение.

Подтверждение перелома

1. рентгенография костей лицевого скелета, при противопоказаниях ультразвуковое исследование (УЗИ) костей носа;
2. при сочетанной травме рентгенография черепа и компьютерная томография (КТ) для выявления повреждений околоносовых пазух, орбиты, скуловой кости, верхней челюсти и черепа.

3.1 Физикальное обследование: осмотр и пальпация

Показания: все пациенты с травмой носа

1. осмотр оториноларинголога: определение характера и выраженности повреждений;
2. пальпация челюстно-лицевой области.

Диагностические признаки

1. отёк, гематомы, ссадины и раны;
2. наличие и выраженность деформации;
3. крепитация отломков;
4. подкожная эмфизема и гематома;
5. состояние области носового клапана, подвижность крыльев носа и подвижной части перегородки.

Для врачебной и судебно-медицинской экспертизы важна фотофиксация повреждений.

3.2 Коагулограмма

Показания

1. травма, сопровождающаяся кровотечением: оценка системы гемостаза и кровопотери, подготовка к возможному хирургическому вмешательству.

3.3 Рентгенография костей лицевого скелета

Показания

1. взрослые и дети **с 3 лет**: выявление костных повреждений.

Рентгенограмма в боковой проекции имеет как диагностическое, так и юридическое значение: в 70,2% случаев она позволяет выявить перелом и характер смещения отломков.

Как правило, повреждаются обе носовые кости, однако встречаются одиночные и множественные переломы, поэтому для уточнения стороны перелома боковые снимки выполняют в положении головы на левой и на правой стороне.

Ограничения

1. чувствительность при переломе костей носа не превышает 70%;
2. смещение во фронтальной плоскости на боковом снимке не визуализируется;
3. у детей **до 3 лет** исследование малоинформативно вследствие слабой оссификации и преобладания хрящевой ткани.

Поэтому отрицательный результат не исключает перелома.

3.4 Рентгенография околоносовых пазух

Показания

1. подозрение на смещение отломков в переднезаднем направлении при отсутствии изменений на боковом снимке (взрослые и дети **с 3 лет**).

Смещение отломков снаружи внутрь, не определяемое на боковых снимках, выявляется на рентгенограмме околоносовых пазух в носоподбородочной проекции.

3.5 Компьютерная томография

КТ лицевого отдела черепа или челюстно-лицевой области и (или) КТ головного мозга.

Показания

1. комбинированные и сочетанные переломы;
2. признаки черепно-мозговой травмы (ЧМТ);
3. неинформативность рентгенографии при клинических признаках перелома;
4. планирование расширенного вмешательства;
5. подозрение на назальную ликворею;
6. тяжёлое состояние;
7. продолжающееся или рецидивирующее носовое кровотечение.

Область исследования определяется сопутствующей патологией.

Методика и оценка

1. чувствительность КТ при переломе приближается к 100%;
2. спиральное сканирование, толщина среза 3 мм;
3. оценивают положение отломков, состояние перегородки носа, повреждения околоносовых пазух, орбиты, мозгового черепа, мягких тканей и головного мозга;
4. перед операцией рекомендуется 3D-реконструкция.

3.6 Ультразвуковое исследование костей носа

Показания

1. противопоказания к лучевым методам;
2. контроль репозиции и сращения отломков (исследование можно повторять).

УЗИ является простым неинвазивным методом, не сопряжено с лучевой нагрузкой и может выполняться повторно для контроля репозиции и сращения отломков. Исследование выполняют в четырёх проекциях: передней продольной, передней поперечной, правой и левой боковой.

3.7 Электрокардиография

Показания к регистрации электрокардиограммы (ЭКГ)

1. травма носа с массивным кровотечением;
2. сочетанная травма носа.

3.8 Консультации специалистов

Показания к консультации

1. офтальмолог: подозрение на повреждение органа зрения;
2. невролог: все пациенты с травмой носа, для своевременного выявления сопутствующей патологии.

---

4. Лечение

Консервативное лечение направлено на уменьшение болевого синдрома и отёка, профилактику бактериального воспаления в зоне повреждения, ускорение заживления и восстановление функций носа.

4.1 Обезболивание

Всем пациентам при отсутствии противопоказаний назначаются анальгетики.

Выраженный болевой синдром и травматический стресс способствуют развитию или утяжелению травматического шока.

Применяют анальгетики-антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) по отдельности или в сочетании; у взрослых и детей, в том числе в послеоперационном периоде, рекомендуется сочетание НПВП с парацетамолом, а также метамизол натрия.

НПВП у детей

1. ибупрофен: с 3 месяцев;
2. кетопрофен: с 15 лет;
3. кетопрофен в гранулах для приготовления раствора: с 6 лет.

Метамизол натрия детям амбулаторно не назначают; в стационаре только при отсутствии других разрешённых детям анальгетиков (риск серьёзных нежелательных явлений).

4.2 Анальгетики у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	1 г внутривенно, инфузия 15 минут	4 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 мг внутримышечно (в таблице рекомендации указано «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 суток
Кеторолак	30 мг внутривенно, внутримышечно	6 ч	60–90 мг	2 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Кетопрофен	100 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	200 мг	не более 2 суток
Лорноксикам	8 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

> В таблице 2 разовая доза диклофенака указана как «75 мл в/м», то есть единица измерения приведена неверно; с учётом структуры таблицы и максимальной суточной дозы 150 мг речь идёт о 75 мг.

4.3 Анальгетики у детей

Парацетамол внутривенно, инфузия 15 минут каждые 4 часа

1. масса тела менее 10 кг: 7,5 мг/кг, не более 30 мг/кг в сутки;
2. масса тела 10–50 кг: 15 мг/кг, не более 60 мг/кг в сутки, но не более 2 г (для 33–50 кг в той же ячейке таблицы указано не более 3 г);
3. масса тела более 50 кг: 1000 мг, не более 4 г в сутки;
4. длительность: 5–7 суток.

Парацетамол внутрь, каждые 6 часов

1. доза: 10–15 мг/кг, не более 60 мг/кг в сутки;
2. длительность: 3–5 суток.

Парацетамол ректально, каждые 6 часов, не более 60 мг/кг в сутки

1. 3–12 месяцев: 50–100 мг;
2. 1–3 года: 100–150 мг;
3. 3–5 лет: 150–200 мг;
4. 5–10 лет: 250–350 мг;
5. 10–14 лет: 350–500 мг;
6. длительность: до 5 суток.

Ибупрофен внутрь, каждые 6–8 часов (в ячейке таблицы указано также «8 ч» без пояснения)

1. 3–6 месяцев: 50 мг, не более 150 мг в сутки;
2. 6–12 месяцев: 50 мг, не более 200 мг в сутки;
3. 1–3 года: 100 мг, не более 300 мг в сутки;
4. 4–6 лет: 150 мг, не более 450 мг в сутки;
5. 6–12 лет: 200–400 мг, не более 800 мг в сутки;
6. 12–17 лет: 200–400 мг, не более 1 г в сутки;
7. длительность: 4 суток.

Ибупрофен ректально

1. 3–9 месяцев: 60 мг каждые 8 часов, не более 180 мг в сутки;
2. 9–24 месяца: 60 мг каждые 6 часов, не более 240 мг в сутки;
3. длительность: не более 3 суток.

Метамизол натрия, каждые 8–12 часов

1. с 15 лет: 500–1000 мг внутривенно, внутримышечно, не более 2 г в сутки, 1–5 суток;
2. 2–14 лет: 50–100 мг/кг внутримышечно, внутривенно, 3 суток;
3. от 3 месяцев до года: 50–100 мг на 10 кг внутримышечно, 3 суток.

> В таблице 3 имеются несогласованности. Для внутривенного парацетамола весовые диапазоны пересекаются: для массы тела 33–50 кг указана максимальная суточная доза 3 г, для 10–50 кг 2 г. Для метамизола натрия детям 2–14 лет указана доза 50–100 мг/кг, детям до года 50–100 мг на 10 кг, то есть в 10 раз меньше в пересчёте на килограмм массы тела. Дозы следует сверить с инструкцией по медицинскому применению.

4.4 Профилактика столбняка и антибактериальная терапия

Вакцина для профилактики столбняка показана при повреждении кожи или слизистой оболочки, если:

1. травма получена при ударе о землю;
2. в рану попала почва.

Экстренную профилактику выполняют в максимально ранние сроки, **вплоть до 20-го дня** после травмы, с учётом инкубационного периода столбняка.

Экстренная профилактика включает

1. первичную хирургическую обработку раны;
2. одновременное введение столбнячного анатоксина, противостолбнячного иммуноглобулина человека или столбнячного антитоксина в соответствии с инструкцией.

При изолированном переломе костей носа, в том числе открытом, рутинное назначение системных антибиотиков до и после операции не рекомендуется.

Профилактическое применение антибиотиков не снижает риск инфекционных осложнений после репозиции костей носа ни у взрослых, ни у детей.

Показания к системным антибиотикам:

1. загрязнённые и гнойные раны кожи и слизистой оболочки;
2. выраженный отёчно-токсический синдром;
3. осложнённая гематома или абсцесс перегородки носа;
4. сочетанная и комбинированная травма;
5. тяжёлая сопутствующая патология.

При явном бактериальном воспалении или высоком риске его развития применяют бета-лактамы широкого спектра действия:

1. цефазолин;
2. цефтриаксон;
3. ампициллин с сульбактамом;
4. амоксициллин с клавулановой кислотой.

При аллергии на бета-лактамы применяют клиндамицин.

Ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой обладают более широкой, чем цефазолин, активностью в отношении грамотрицательных и анаэробных бактерий.

Препарат	Доза
Ампициллин и сульбактам	Внутримышечно и внутривенно. Взрослым в зависимости от тяжести инфекции 3–12 г в сутки в 3 введения, детям — 150 мг/кг в сутки в 3 введения (новорождённым — в 2), в течение 5–14 дней.
Амоксициллин и клавулановая кислота	Внутривенно. Взрослым и детям старше 12 лет — по 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки, детям младше 12 лет — 25 мг/кг 3 раза в сутки, в течение 5–14 дней.

4.5 Противоотёчная, гемостатическая и местная терапия

При выраженном отёке взрослым и детям **старше 15 лет** назначаются ангиопротекторы, что позволяет выполнить репозицию отломков в более ранние сроки и предупредить осложнения.

Троксерутин (взрослым и детям **старше 15 лет**) или гель гепарина натрия наносится местно на спинку носа на неповреждённую кожу 2 раза в день до регресса отёка.

При обильном кровотечении, а также для профилактики интра- и послеоперационного кровотечения назначаются гемостатические средства.

Кровотечение возможно из полости носа и из повреждённых мягких тканей при открытых ранах. Механическая остановка кровотечения, как правило, дополняется назначением гемостатиков: этамзилата, транексамовой или аминокапроновой кислоты.

Препарат	Взрослые	Дети
Этамзилат	Для остановки кровотечения — 250–500 мг внутривенно или внутримышечно, затем по 250 мг каждые 4–6 часов. При репозиции — 250–500 мг за час до операции, при необходимости 250–500 мг во время операции и 500–750 мг равномерно в течение суток после неё.	10–15 мг/кг в сутки в 3–4 приёма, 5–10 дней. Во время операции — 8–10 мг/кг внутривенно, затем 10–15 мг/кг в течение суток.
Транексамовая кислота	Внутривенно капельно или медленно струйно со скоростью 1 мл/мин (50 мг/мин), 10–15 мг/кг каждые 6–8 часов до остановки кровотечения.	Старше 1 года — 20 мг/кг в сутки до остановки кровотечения.
Аминокапроновая кислота	Внутривенно капельно: 4–5 г за первый час, при продолжающемся кровотечении — по 1 г в час не более 8 часов; при необходимости инфузии повторяются каждые 4 часа; не более 30 г в сутки. Курс 3–14 дней.	100 мг/кг за первый час, затем 33 мг/кг в час; не более 18 г/м² в сутки (до года — 3 г, 2–6 лет — 3–6 г, 7–10 лет — 6–9 г, старше 10 лет — как взрослым). При острой кровопотере: до года — 6 г, 2–4 года — 6–9 г, 5–8 лет — 9–12 г, 9–10 лет — 18 г.

> Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере превышают указанные рядом максимальные суточные дозы: например, до года 6 г при максимуме 3 г, в 9–10 лет 18 г при максимуме 6–9 г.

Всем пациентам для облегчения носового дыхания назначаются деконгестанты и другие назальные препараты.

Сосудосуживающие спреи и капли уменьшают реактивный отёк слизистой оболочки после травмы и облегчают носовое дыхание после операции.

Препарат	Доза
Фенилэфрин 0,125%	Интраназально: до года — 1 капля, 1–6 лет — 1–2 капли, старше 6 лет — 3–4 капли до 3 раз в сутки, до 7 дней.
Оксиметазолин	До года — 0,01%, 1–6 лет — 0,025%, старше 6 лет — 0,05%; по 1–2 капли интраназально 2–3 раза в сутки, до 5 дней.
Ксилометазолин	2–6 лет — 0,05%, старше 6 лет — 0,1%; спрей по 1 дозе 2–3 раза в сутки, до 5 дней.

При повреждении кожи или слизистой оболочки с признаками инфицирования раны или высоким риском инфицирования назначаются местные антисептики.

1. бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (в форме спрея не применяют у детей **до 3 лет**);
2. повидон-йод;
3. хлоргексидин.

Кратность обработки раны по выраженности воспаления и количеству экссудата; обработку продолжают до разрешения инфекции или начала заживления.

Всем пациентам показано промывание полости носа для ускорения заживления слизистой оболочки.

Уход за полостью носа после травмы и операции ускоряет заживление и предупреждает осложнения, например синехии. Применяются стерильные изотонические растворы морской воды 2–3 раза в день до эпителизации слизистой оболочки и стихания воспаления.

4.6 Хирургическое лечение

Неотложные мероприятия при травме носа включают остановку кровотечения и первичную хирургическую обработку открытых ран. При переломе хирургическое лечение направлено на восстановление формы наружного носа, устранение смещения внутриносовых структур и восстановление дыхания.

При открытых ранах и открытых переломах выполняется хирургическая обработка раны с иссечением инфицированных тканей и наложением косметического шва.

Перед наложением шва необходимы тщательная ревизия раны, удаление инородных тел и зондирование раневого канала.

При неэффективности гемостатической терапии и тампонады показана хирургическая остановка кровотечения.

Метод определяется источником кровотечения.

1. из передних отделов: отслойка участка мукоперихондрия с последующей тампонадой, выскабливание расширенного сосуда, криокоагуляция или электрокаустика;
2. обильное кровотечение: перевязка наружной сонной артерии, эндоскопическое клипирование сосудов или эндоваскулярная эмболизация;
3. из решётчатых артерий: этмоидотомия наружным, внутренним или эндоназальным доступом.

При гематоме или абсцессе перегородки носа показаны вскрытие и дренирование.

После вскрытия выполняют переднюю тампонаду, перевязки проводят ежедневно до прекращения отделяемого.

При травматической деформации наружного носа показаны репозиция костей и фиксация отломков для восстановления формы носа и носового дыхания.

Сроки операции

1. ранняя: **в первые 7 суток** после травмы;
2. отложенная: **на 8–15-е сутки**;
3. плановая: **через 6 месяцев** и позднее.

Показания к ранней операции:

1. перелом костей носа с минимальным или умеренным отёком;
2. комбинированная травма наружного носа с повреждением внутриносовых структур или околоносовых пазух;
3. гематома перегородки носа.

Раннее вмешательство позволяет избежать септических осложнений и синехий.

Операция может быть отложена **до 15 суток**:

1. при тяжёлом состоянии;
2. при выраженном отёке;
3. при комбинированных переломах костей и перегородки носа;
4. при ранениях лица.

> Согласно классификации в разделе 1.5, острая стадия, в которой репозиция костей выполняется по стандартной методике, продолжается 14 дней, а по истечении двух недель репозиция возможна только в сочетании с операцией на перегородке носа. В разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.

Показания к плановому хирургическому лечению переломов (риносептопластике):

1. сочетанная травма с переломом основания черепа и назальной ликвореей;
2. тяжёлые функциональные нарушения.

Способы репозиции

1. наружный (пальцевой);
2. эндоназальный (инструментальный);
3. экстраназальный (открытый): при одновременном вмешательстве по поводу внутричерепной травмы или травмы лобных пазух и верхней челюсти.

У детей наружный способ эффективен лишь в 22% случаев, поэтому предпочтительна эндоназальная репозиция элеваторами Манакова или Волкова с последующей передней тампонадой.

При комбинированных назосептальных переломах в остром периоде репозицию костей сочетают с септопластикой. При сочетанной травме репозицию предпочтительно проводить совместно с хирургами других специальностей, если вмешательство выполняется под наркозом.

При подозрении на черепно-мозговую травму репозиция откладывается до осмотра невролога или нейрохирурга и проведения необходимых исследований.

4.7 Анестезия, тампонада и фиксирующая повязка

При операциях по поводу открытых и закрытых переломов и смещения внутриносовых структур проводится анестезия наружного носа и полости носа.

Взрослым при изолированной травме применяют аппликационную анестезию слизистой оболочки полости носа в сочетании с внутримышечным введением анальгетиков или проводниковую анестезию артикаином. Детям рекомендуется сочетанная анестезия.

При переломах костей наружного носа и внутриносовых структур выполняется передняя тампонада для удержания сопоставленных отломков и остановки кровотечения при травме слизистой оболочки.

Тампон вводят на стороне деформации и удаляют **на 2–3-и сутки** после операции; срок определяется подвижностью отломков. Преимущества длительной тампонады (**более 3–5 дней**) после репозиции не доказаны.

При переломах, сложных травмах и после операций накладывается пращевидная повязка для профилактики смещения отломков.

Наружная шина после закрытой репозиции рутинно не применяется и показана только при тяжёлых оскольчатых переломах.

При выраженных реактивных воспалительных явлениях показана консультация физиотерапевта.

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области и магнитотерапия уменьшают воспаление и отёк и ускоряют заживление.

Режим на период лечения

1. ограничение физической активности;
2. исключение действий, способных привести к смещению отломков, в том числе во сне;
3. полноценное витаминизированное легкоусвояемое питание;
4. не рекомендуются горячая ванна, душ, сауна и бассейн.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

После операций по поводу деформации наружного носа или перегородки носа пациент **в течение года** находится под наблюдением оториноларинголога. Обязательные осмотры:

1. через 1 месяц;
2. через 3 месяца;
3. через 6 месяцев;
4. через год после операции.

Профилактика травм основана на общих социальных мерах предупреждения травматизма.

К ним относятся соблюдение техники безопасности в детских учреждениях, на производстве и в быту, разъяснительная работа с родителями и пропаганда здорового образа жизни.

5.1 Показания к госпитализации

1. тяжёлое состояние;
2. выраженный отёк;
3. кровотечение;
4. выраженный болевой синдром;
5. комбинированные переломы костей и перегородки носа с повреждением околоносовых пазух и ранениями лица;
6. травматическая деформация носа со смещением перегородки или нарушением дыхания;
7. тяжёлая сопутствующая патология;
8. приём антикоагулянтов или антиагрегантов;
9. осложнения: гематома и абсцесс перегородки носа, воспаление околоносовых пазух и соседних областей;
10. необходимость закрытой репозиции.

Пациента выписывают при:

1. удовлетворительном состоянии и нормальных клинических показателях;
2. улучшении формы носа и носового дыхания;
3. отсутствии осложнений.

Прогноз благоприятный при проведении лечения в соответствии с рекомендациями и выполнении пациентом назначений врача.

Пациенту разъясняется, что при выраженном отёке лица, деформации носа, повреждении мягких тканей, носовом кровотечении или нарушении дыхания необходима экстренная консультация оториноларинголога, поскольку запоздалое лечение может привести к опасным осложнениям.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	815_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 2 разовая доза диклофенака указана как «75 мл в/м» вместо миллиграммов.
- В таблице 3 для внутривенного парацетамола пересекаются весовые диапазоны с разными максимальными суточными дозами (33–50 кг: 3 г; 10–50 кг: 2 г); для метамизола натрия доза у детей 2–14 лет (50–100 мг/кг) в 10 раз больше в пересчёте на килограмм, чем у детей до года (50–100 мг на 10 кг). Для ибупрофена внутрь в графе интервала указаны одновременно «6–8 ч» и «8 ч» без пояснения.
- Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере (до года 6 г, в 9–10 лет 18 г) превышают указанные рядом максимальные суточные дозы (3 г и 6–9 г).
- Острая стадия перелома в разделе 1.5 составляет 14 дней, тогда как в разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.

Клинические рекомендации

Травма уха

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S00.4** — Поверхностная травма уха **S01.3** — Открытая рана уха **S09.2** — Травматический разрыв барабанной перепонки
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/812_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рекомендация охватывает поверхностную травму уха (ПТУ: ушиб, отогематома, раны, дефекты раковины) и травматический разрыв барабанной перепонки (ТРБП).
- Отогематому устраняют всегда: **до 48 часов** и **менее 2 см** — аспирация иглой 18G, больше или позже — разрез и дренирование; затем давящая повязка.
- Разрыв барабанной перепонки (попадание воды в ухо недопустимо):
  1. свежая перфорация **менее 25%** площади без выделений из уха, кроме взрывной травмы: наблюдение **1–3 месяца**;
  2. разрыв **менее 50%** площади, кроме взрывной травмы: консервативная миринготластика;
  3. стойкая перфорация (сохраняется **более 3 месяцев**): тимпанопластика у всех пациентов, в том числе после взрывной травмы.
- Инфицированная рана и перихондрит: ранние системные антибиотики **7–10 дней**, фторхинолоны — только взрослым; при инфицированных ранах — столбнячный анатоксин.
- Экстренная госпитализация: осложнения (перихондрит, мастоидит) и необходимость операции.

2. Клиническая картина и классификация

Определения

Термин	Определение
Поверхностная зона уха (ПЗУ)	ушная раковина, перепончато-хрящевая часть слухового прохода, мягкие ткани сосцевидной области
Поверхностная травма уха (ПТУ)	механическое воздействие (удар, ушиб, укус, ранение) в поверхностной зоне уха
Ушиб уха	повреждение мягких тканей без видимого нарушения их целостности
Отогематома	скопление крови между хрящом и надхрящницей ушной раковины после механического воздействия
Посттравматический дефект ушной раковины	частичное нарушение целостности мягких тканей или полное отсутствие раковины (ампутация)
Перихондрит ушной раковины	острое воспаление надхрящницы с переходом на кожу раковины и перепончато-хрящевую часть прохода, без мочки
Посттравматический стеноз слухового прохода	сужение наружного слухового прохода после травмы
Акубаротравма	повреждение среднего и внутреннего уха от одновременного резкого перепада давления и звука высокой интенсивности
Баротравма уха	повреждение среднего и внутреннего уха от резкого перепада давления в слуховом проходе или барабанной полости
Травматический разрыв барабанной перепонки (ТРБП)	нарушение целостности барабанной перепонки от внешних причин

2.1 Этиология

Поверхностная травма

Поверхностная травма уха возникает при ударе, ушибе, укусе или ранении (колотом, резаном, рваном, огнестрельном) и может привести к утрате органа или значительному обезображиванию с частичной утратой слуховой функции.

1. **ушиб**: закрытое повреждение мягких тканей без видимого нарушения их целостности; хрящ ушной раковины не повреждается, подкожного и поднадхрящничного кровоизлияния нет;
2. **отогематома**: скопление крови между хрящом и надхрящницей при более выраженном воздействии; возникает у борцов, боксёров, лиц тяжёлого физического труда, при длительном давлении жёсткого головного убора или твёрдой подушки, при ударе по ушной раковине или падении на неё;
3. **посттравматический дефект ушной раковины** при укусах, порезах, ранениях: от частичного нарушения целостности мягких тканей до полного отсутствия раковины (ампутации).

Инфицирование раны может привести к перихондриту ушной раковины, её деформации и рубцовой атрезии наружного слухового прохода.

Причины травматического разрыва барабанной перепонки

1. механические: острые предметы, самостоятельная чистка уха («Q-tip injury»), ятрогенно при промывании, удалении инородных тел, аспирации;
2. баротравма: резкий перепад давления воздуха при авиаперелёте или воды при погружении, удар ладонью по уху, взрывная волна;
3. сочетанная травма основания черепа: поперечный перелом височной кости, огнестрельное ранение уха;
4. термические: окалина при электросварке, удар молнии;
5. химические: агрессивные жидкости.

У детей чаще тупая травма, баротравма, инородное тело; проникающая травма ватной палочкой, спичкой, шпилькой — самим ребёнком, ухаживающими или ятрогенно при удалении инородного тела.

80–97% разрывов заживают сами **за 2–4 недели** независимо от локализации и выделений, влияет лишь размер дефекта. При взрывной травме с большими перфорациями — в 56–82%, **до 3 месяцев**. Если в ухо попадает вода — риск инфицирования; после минно-взрывной травмы возможна интратимпанальная холестеатома уже **через 6 месяцев**.

2.2 Классификация

Поверхностная травма

1. закрытая (ушиб) и ранения;
2. поверхностная (без повреждения височной кости) и глубокая (с повреждением височной кости).

Разрыв барабанной перепонки

1. по времени: свежая перфорация (**менее 3 месяцев**) и стойкая;
2. с гноетечением или сухая;
3. по размеру: малая — **менее 25%** площади (менее 1 квадранта), средняя — 25–50% (1–2 квадранта), большая — более 75% (более 2 квадрантов).

Нарушения слуха, в том числе при акубаротравме, классифицируют по действующей классификации потери слуха.

Дефекты ушной раковины классифицируют по Ю. Н. Ростокину (1975): частичные верхнего, среднего, нижнего отдела, субтотальные, тотальные; и по H. Weerda (1998): центральные, периферические, частичная реконструкция, дефекты мочки, задние, субтотальные, полная потеря раковины, дефекты околоушных мягких тканей, после ожогов.

2.3 Клиническая картина

Отогематома

1. обычно в верхней половине наружной поверхности раковины;
2. флюктуирующая округлая припухлость синеватого или багрового оттенка;
3. мочку не затрагивает;
4. пальпация обычно безболезненна.

Перихондрит: следствие несвоевременного удаления крови из отогематомы.

1. выраженная боль в раковине и слуховом проходе;
2. раковина увеличена, контуры сглажены, мочка не вовлечена;
3. флюктуация при гное между надхрящницей и хрящом;
4. при позднем обращении гнойное расплавление хряща, секвестры, деформация раковины;
5. лихорадка, бессонница из-за пульсирующей боли, иногда озноб;
6. иррадиация боли в височную, затылочную и шейную область.

Ранения: возможен частичный или полный отрыв раковины; кровотечение из ветвей наружной сонной артерии обычно умеренное.

Признаки повреждения глубжележащих структур

1. интенсивное кровотечение, требующее неотложной помощи, возникает при повреждении затылочной, височной, задней ушной артерий или их ветвей;
2. ограничение подвижности нижней челюсти позволяет заподозрить повреждение её сустава;
3. выделение слюны через рану указывает на повреждение околоушной слюнной железы;
4. парез лицевого нерва указывает на повреждение его периферических ветвей;
5. при более глубоком распространении инфекции могут развиться лабиринтит и внутричерепные осложнения.

Объём повреждения раковины зависит от силы и направления воздействия: от ссадин и кровоподтёков до отрыва и размозжения.

Разрыв барабанной перепонки: снижение слуха, заложенность, небольшой шум; непосредственно после травмы возможны кровянистые выделения из уха.

1. акубаротравма: снижение слуха вплоть до глухоты, головокружение, нарушение равновесия;
2. при взрывной травме из-за тяжёлого общего состояния у половины пострадавших повреждение слуха не диагностируют или диагностируют поздно;
3. проникающая травма у детей: разрыв цепи косточек, повреждение лицевого нерва и подножной пластинки стремени, перилимфатическая фистула, гемотимпанум; потеря слуха, головокружение, нистагм, атаксия.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании анамнеза, общего осмотра с тщательным осмотром поверхностной зоны уха и барабанной перепонки, отоскопии, заключений других специалистов и лабораторных данных.

Поверхностная травма: жалобы

1. боль, отёк мягких тканей;
2. кровотечение, дефект тканей раковины, ссадины, кровоподтёки;
3. снижение слуха, головокружение;
4. недомогание, слабость, лихорадка, головная боль.

Разрыв барабанной перепонки

1. механизм: перепад давления (удар ладонью, ныряние, взрывная волна), острые предметы или чистка уха, перелом основания черепа при минно-взрывной травме;
2. резкая боль в момент травмы, снижение слуха, шум, головокружение, нарушение равновесия;
3. кровь или ликвор из уха (перелом основания черепа);
4. звук выходящего воздуха при продувании или сморкании;
5. после попадания воды — слизистые или гнойные выделения.

3.1 Осмотр и отоскопия

Показания к осмотру оториноларинголога

1. все пациенты с подозрением на травму уха: первичный осмотр.

Местные признаки поверхностной травмы

1. гиперемия, отёк мягких тканей;
2. флюктуация при скоплении крови или гнойного экссудата между надхрящницей и хрящом;
3. дефекты раковины (частичный или полный отрыв), хрящевой части прохода, околоушной области;
4. кровотечение.

Отоскопия при разрыве барабанной перепонки

1. свежая перфорация: рваные, не омозолелые края, вывернутые кнаружи или в барабанную полость; иногда кровь в проходе;
2. стойкая перфорация: омозолелые края;
3. диагноз акубаротравмы (баротравмы) при соответствующем анамнезе устанавливается только при отоскопически видимом разрыве, без него картина сходна с туботитом.

Дефекты кожи слухового прохода, кровь в нём или подозрение на отоликворею могут указывать на перелом основания черепа. Системные признаки осложнений: лихорадка, интоксикация, выраженная диффузная головная боль.

3.2 Общий и биохимический анализ крови

Всем пациентам с травмой уха: развёрнутый общий и биохимический анализы крови.

3.3 Микробиологическое исследование отделяемого

Всем пациентам с травмой уха: посев гнойного отделяемого с определением чувствительности.

При гнойном перихондрите чаще всего синегнойная палочка; также золотистый стафилококк, кишечная палочка, протей.

3.4 Камертональные пробы и тональная аудиометрия

Показания

1. взрослые с травмой уха и снижением слуха: исключить острую сенсоневральную тугоухость.

Аудиометрия показывает кондуктивную тугоухость и её степень; сенсоневральный компонент указывает на повреждение внутреннего уха. У маленьких детей камертональные пробы трудны.

3.5 КТ височной кости

Показания

1. осложнения: перихондрит, абсцесс;
2. подозрение на повреждение височной кости, слуховых косточек, перилимфатическую фистулу.

Перфорация в задне-верхнем квадранте при проникающей травме может указывать на повреждение косточек или внутреннего уха.

Сопутствующие повреждения (перелом челюсти, околоушной железы, лицевого нерва): консультации невролога, челюстно-лицевого хирурга, нейрохирурга.

---

4. Лечение

Ушибы ушной раковины специального лечения не требуют; ссадины обрабатывают антисептиком, накладывают асептическую повязку или наклейку.

4.1 Обезболивание

Показания

1. поверхностная травма уха: НПВП по выраженности боли.

НПВП у детей

1. ибупрофен: с 3 месяцев — свечи и суспензия, с 6 лет — таблетки, с 12 лет — капсулы;
2. кетопрофен: с 6 лет — гранулы внутрь, с 15 лет — парентерально.

Обезболивание у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Диклофенак	75 мг в/м (в КР «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 сут
Кеторолак	30 мг в/в, в/м	в КР «6- ч»	60–90 мг	2 сут
Кетопрофен	100 мг в/в, в/м	12 ч	200 мг	не более 2 сут
Лорноксикам	8 мг в/в, в/м	12 ч	16 мг	1–7 сут
Декскетопрофен	50 мг в/в, в/м	8–12 ч	150 мг	2 сут

Обезболивание у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Ибупрофен внутрь	10–12 лет 300 мг; 7–9 лет 200 мг; 4–6 лет 150 мг; 1–3 года 100 мг; 6–12 мес 50 мг; 3–6 мес 50 мг	8 ч; 6–8 ч (в таблице КР интервалы не сопоставлены с возрастами построчно)	10–12 лет 900 мг; 7–9 лет 600 мг; 4–6 лет 450 мг; 1–3 года 300 мг; 6–12 мес 200 мг; 3–6 мес 150 мг	3–5 сут
Ибупрофен ректально	3–9 мес 60 мг; 9–24 мес 60 мг	3–9 мес 8 ч; 9–24 мес 6 ч	3–9 мес 180 мг; 9–24 мес 240 мг	не более 3 дней
Кетопрофен в/в, в/м	с 15 лет 100 мг	12 ч	200 мг	не более 2 сут
Кетопрофен внутрь	старше 6 лет 40 мг	8 ч	120 мг	не более 2 сут

4.2 Лечение ран

Показания к местному лечению антисептиками и антибактериальными мазями

1. поверхностная травма уха: местно антисептики и антибактериальные мази.

Средства

1. бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний, повидон-йод, хлоргексидин;
2. мази у взрослых: хлорамфеникол, неомицин, бацитрацин + неомицин, мупироцин;
3. у детей неомицин, бацитрацин, мупироцин не применяют.

Кратность определяется выраженностью воспаления и экссудации; обрабатывают до разрешения инфекции или начала заживления.

Профилактика столбняка: при инфицированных и контаминированных ранах вводится столбнячный анатоксин.

Показания к системной антибактериальной терапии

1. инфицированная рана;
2. перихондрит ушной раковины.

Препараты

1. цефалоспорины III и IV поколения, фторхинолоны;
2. длительность около **7–10 дней**;
3. фторхинолоны только взрослым; детям — только цефалоспорины IV поколения.

4.3 Разрыв барабанной перепонки

Показания к выжидательной тактике

1. разрыв **менее 25%** площади, кроме взрывной травмы.

При появлении выделений из уха назначаются системные антибиотики.

Наблюдение длится **1–3 месяца** при свежей перфорации (**менее 3 месяцев**), площади **менее 25%** и отсутствии выделений из уха. Если перфорация сохраняется, показана тимпанопластика.

Показания к консервативной миринготомии

1. разрыв **менее 50%** площади, кроме взрывной травмы.

Консервативная миринготомия заключается в тампонаде слухового прохода коллагеновой гемостатической губкой поверх дефекта.

После процедуры

1. не допускать воды в ухо;
2. не вводить препараты в барабанную полость;
3. без самопродувания, чихания, сморкания;
4. осмотр **через 2–4 недели**, раньше — при выделениях или снижении слуха;
5. материал удаляют **не ранее 4 недель**.

Под местной анестезией лидокаином (10% аппликационно или 1% инфильтрационно, кроме детей до 1 года) с оптикой, через ушную воронку; после туалета и при необходимости освежения краёв материал больше перфорации укладывают поверх неё. Детям вмешательство выполняют под наркозом; используют и папиросную бумагу.

Показания к тимпанопластике

1. стойкая перфорация после травматического разрыва (сохраняется **более 3 месяцев**), у всех пациентов.

Операция показана даже при признаках заживления, если подозревают

1. перелом или смещение слуховых косточек;
2. холестеатому среднего уха;
3. фистулу лабиринтных окон: вестибулярные нарушения **более 2 недель**, костно-воздушный интервал **более 30 дБ**, смешанная тугоухость.

Показания к диагностической тимпанотомии у детей

1. травма уха с вестибулярными симптомами у ребёнка.

Тимпанотомия позволяет выявить и закрыть перилимфатическую фистулу.

Признаки, при которых подозревают перилимфатическую фистулу

1. сенсоневральная тугоухость;
2. нарушение равновесия, головокружение;
3. нистагм в сторону поражения;
4. перфорация в задне-верхнем квадранте.

Под эндотрахеальным наркозом поднимают тимпаномеатальный лоскут, осматривают окна; при явной травме удаляют или репонируют костные фрагменты. Если после аспирации прозрачная жидкость скапливается у окон **не менее 5 минут** наблюдения — фистула; окна закрывают жиром или фасцией, вестибулярные симптомы обычно проходят.

4.4 Отогематома, перихондрит, раны

Показания к устранению отогематомы

1. все пациенты с отогематомой: устранение для профилактики перихондрита.

Тактика

1. **менее 48 часов** после травмы и диаметр **менее 2 см**: аспирация иглой 18G, вкол у основания гематомы;
2. больше **2 см** или позже **48 часов**: разрез и дренирование без косметического ущерба;
3. профилактика рецидива: циркулярная давящая повязка, матрасные швы, фиксация магнитами.

Анестезия

1. 0,5% прокаин: взрослым и детям старше 12 лет;
2. 2% лидокаин: только взрослым.

Гнойный перихондрит: вскрытие и дренирование абсцесса раковины с удалением некротизированных тканей.

Частичный или полный дефект раковины: устранение дефекта. Хирургическую обработку проводят как можно раньше, с учётом косметики: удаляют только явно нежизнеспособные ткани, первичные швы, при большом натяжении — направляющие.

Ранение перепончато-хрящевой части слухового прохода: стерильные мягкие эластичные трубки в просвет для его восстановления.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация

1. осложнения поверхностной травмы: перихондрит, мастоидит и другие;
2. необходимость операции: устранение дефекта раковины, слухового прохода и другие.

Выписка

1. нормальное общее состояние: нет лихорадки и интоксикации;
2. нормальный общий анализ крови;
3. нормальное заживление ран.

После выписки из стационара пациент находится на диспансерном наблюдении у оториноларинголога.

Профилактика: техника безопасности на производстве и в спорте, средства защиты головы — шлемы, каски.

При адекватном лечении прогноз благоприятный.

Осложнения без лечения или при неадекватном лечении

1. перихондрит;
2. острый гнойный средний отит, мастоидит, лабиринтит;
3. внутричерепные осложнения;
4. флегмона, абсцесс.

При разрыве перепонки прогноз благоприятный; воспаление среднего уха удлиняет течение, но не меняет исход.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма уха»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 18.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	`812_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Таблица 1 (обезболивание у взрослых): разовая доза диклофенака записана как «75 мл в/м» — по смыслу 75 мг; интервал кеторолака записан неполно («6- ч»). Сверяйте с инструкцией препарата.
- Таблица 2 (обезболивание у детей): для ибупрофена внутрь интервалы приёма не сопоставлены с возрастными группами построчно.

Клинические рекомендации

Химический ожог пищевода

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**T28.5** — Химический ожог рта и глотки **T28.6** — Химический ожог пищевода **T28.7** — Химический ожог других отделов пищеварительного тракта
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"; Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"; Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"; Региональная Общественная организация "Национальное общество Торакальных Хирургов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/821_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Химический ожог пищевода представляет собой местное повреждение стенки пищевода веществом прижигающего действия, принятым внутрь; ожог желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) сопровождается токсическим резорбтивным действием.
- Госпитализации подлежат все пациенты с клинико-анамнестическими признаками химического ожога ЖКТ.
- В приёмном отделении показаны осмотр оториноларинголога для оценки вовлечения дыхательных путей и осмотр токсиколога. При отёке дыхательных путей и угрозе асфиксии выполняется интубация трахеи, при невозможности интубации накладывается трахеостома. **Отсутствие ожога полости рта и ротоглотки не исключает ожог пищевода**.
- Эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) выполняют **в первые 12–48 часов**; при попадании дисковой батарейки или кристаллов перманганата калия ЭГДС проводится **экстренно**. Степень ожога оценивают по классификации Zargar.
- Взрослым **с 18 лет** показана экстренная компьютерная томография (КТ) грудной и брюшной полости с внутривенным контрастированием.
- Промывание желудка без зонда с вызыванием рвоты и применение нейтрализаторов не рекомендуются.
- Рубцы формируются за **4–6 недель**. Стриктуры лечат бужированием (поддерживающее бужирование **12 месяцев**, не более **24 месяцев**), при его неэффективности показана пластика пищевода. Диспансерное наблюдение хирурга продолжается **3 года**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. химический ожог пищевода: местное повреждение стенки пищевода при случайном или преднамеренном приёме внутрь химического вещества прижигающего действия;
2. химический ожог ЖКТ: повреждение полости рта, глотки, пищевода и желудка, сопровождающееся токсическим резорбтивным действием.

Послеожоговым стенозом пищевода называют сужение просвета и деформацию стенки пищевода разной протяжённости на разных уровнях за счёт рубцовой ткани в месте воздействия.

2.2 Этиология

Причиной химического ожога является случайный или преднамеренный приём внутрь химических веществ прижигающего действия; характер поражения зависит от вида вещества.

Основные группы веществ, вызывающих химические ожоги

1. **щелочи** входят в состав моющих средств, средств для прочистки труб, электролита батареек; вызывают колликвационный некроз и глубоко поражают стенку пищевода вплоть до трансмурального некроза и перфорации;
2. **кислоты** входят в состав консервантов, отбеливателей, средств от накипи; вызывают коагуляционный некроз, а разрушение клеточных мембран и сосудистой стенки приводит к всасыванию токсина в кровоток;
3. **сильные окислители** (перманганат калия, перекись водорода); кристаллы перманганата калия поражают не только пищевод, но и глотку, надгортанник и голосовые складки;
4. **дисковые батарейки** (у детей): первичным механизмом повреждения является электролиз с образованием щелочи и кислоты; кроме того, возможны утечка электролита, пролежень стенки пищевода и его непроходимость.

Дети чаще всего получают ожог в 1–3 года (80,3%), приём непреднамеренный; подростки чаще принимают вещество с суицидальной целью. Взрослые чаще получают ожог в 30–40 лет, в 85–87% случаев по ошибке в состоянии алкогольного опьянения; у женщин преобладают суицидальные попытки. Приём залпом 50–100 мл и более вызывает глубокие ожоги рта, глотки, пищевода, желудка и кишки, пациенты погибают в первые 2–3 суток.

2.3 Классификация

По этиологии

1. ожоги кислотами;
2. ожоги щелочами;
3. прочие.

По глубине поражения

1. I степень: катаральное поражение;
2. II степень: эрозивное поражение, не глубже мышечной пластинки слизистой оболочки;
3. III степень: язвенное поражение слизистой оболочки и подслизистого слоя;
4. IV степень: язвенно-некротическое поражение слизистой оболочки, подслизистого и мышечного слоёв.

По времени развития непроходимости

1. ранняя: **до 3–4 недель**;
2. поздняя: позже 1 месяца.

Стадии

1. острая (токсикогенная);
2. отторжения некротических тканей;
3. формирования рубцовых изменений;
4. отдалённые сроки.

По степени сужения

1. 1-я, избирательная: 1,0–1,5 см, не проходит грубая пища;
2. 2-я, компенсированная: 0,3–0,5 см, проходит полужидкая пища;
3. 3-я, субкомпенсированная: менее 0,3 см, проходит только жидкость;
4. 4-я: обратимая полная непроходимость;
5. 5-я: полная облитерация.

По протяжённости

1. короткие (мембранозные);
2. циркулярные до 3 см;
3. трубчатые более 3 см;
4. чёткообразные;
5. тотальное поражение.

По локализации

1. высокие (вход в пищевод, шейный отдел);
2. срединные;
3. низкие (кардиальные);
4. комбинированные.

По осложнениям

1. ложные дивертикулы;
2. ложные ходы;
3. рубцовое укорочение пищевода;
4. свищи (пищеводно-бронхиальные, пищеводно-трахеальные).

По сочетанности

1. изолированный ожог пищевода;
2. сочетанный ожог пищевода и желудка или двенадцатиперстной кишки.

Эндоскопическая классификация Zargar S. A.

Степень	Эндоскопическая картина
0	нормальная слизистая оболочка
I	отёк и эритема слизистой оболочки
IIA	кровоизлияния, эрозии, волдыри, поверхностные язвы
IIB	глубокие и циркулярные язвы
IIIA	очаговые тёмно-серые или коричнево-чёрные язвы
IIIB	обширные тёмно-серые или коричнево-чёрные язвы
IV	перфорация

2.4 Клиническая картина

Острая токсикогенная стадия длится **первые 3–7 суток**. **Отсутствие ожога полости рта и ротоглотки не исключает ожог пищевода**.

Сразу после приёма вещества

1. боль, дисфагия;
2. осиплость голоса;
3. гиперсаливация, у детей резкое беспокойство;
4. возможна фебрильная лихорадка;
5. ожоги лица, шеи, груди.

Системные синдромы

1. экзотоксический шок;
2. дыхательная недостаточность: аспирация, пневмония, отёк и стеноз гортани;
3. гемолиз и нефропатия (особенно при отравлении уксусной кислотой), метаболический ацидоз; при отравлении щелочами алкалоз;
4. токсическая коагулопатия вплоть до ДВС-синдрома, гепатопатия.

При обширных ожогах III–IV степени без лечения пациенты погибают в первые 1–2 суток.

Стадия отторжения некротических масс, или мнимого благополучия, продолжается **1–3 недели**: уменьшаются отёк и слюнотечение, нормализуется температура тела, пациент начинает есть. **Выписка пациента с неустановленной степенью ожога недопустима**. При тяжёлых ожогах и осложнениях этой стадии может не быть.

Токсикологи выделяют соматогенную стадию (первые 2 недели). Ранние осложнения (1–2-е сутки): механическая асфиксия при ожоге рта и верхних дыхательных путей, делирий, панкреатит. Поздние осложнения (после 3-х суток): трахеобронхит, пневмония, психоз.

Стадия формирования рубцов длится **4–6 недель**.

Проявления

1. нарастающая дисфагия, как правило к концу 3-й недели, сначала для твёрдой пищи, затем для жидкой;
2. пищеводная рвота без кислого запаха;
3. потеря массы тела.

Через **15–20 лет** в рубцах и над стенозом нередко развивается плоскоклеточный рак.

При попадании дисковой батарейки и кристаллов перманганата калия у детей острая стадия длится не более суток. При отравлении перманганатом калия слизистая оболочка рта окрашена в тёмно-фиолетовый цвет. Мнимого благополучия, как правило, нет, нераспознанный ожог напоминает бронхит или пневмонию.

Острая стадия

1. гиперсаливация, дисфагия;
2. беспокойство, отказ от питья и еды.

Осложнения

1. дисковая батарейка: стеноз пищевода, парез гортани, перфорация, медиастинит, трахеопищеводный и аортопищеводный свищ;
2. перманганат калия: стеноз глотки, стеноз гортани.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: приём химического вещества внутрь;
2. жалоб;
3. осмотра: ожог лица и полости рта, специфический запах;
4. данных инструментальных исследований.

3.1 Жалобы и анамнез

Жалобы

1. боль во рту, за грудиной и в эпигастрии;
2. боль при глотании, дисфагия;
3. слюнотечение;
4. осиплость голоса;
5. рвота.

3.2 Первичный осмотр

Оценивают

1. следы ожога на подбородке и в углах рта;
2. состояние слизистой оболочки полости рта;
3. пульс и артериальное давление.

В острой стадии пациент беспокоен, кожа бледная, при тяжёлом отравлении отмечается акроцианоз. Язык, щёки, язычок и дужки отёчны и гиперемированы, некрозы имеют вид серых, жёлтых или чёрных плёнок; ощущается запах уксуса, формалина или нашатырного спирта; тахикардия. При экзотоксическом шоке отмечаются одышка, холодный пот, нитевидный пульс, гипотония. При ожоге желудка выявляется защитное напряжение мышц живота, затем симптомы раздражения брюшины; в рвотных массах возможна примесь крови.

В приёмном отделении показаны осмотр оториноларинголога для оценки вовлечения начальных отделов дыхательных путей и осмотр токсиколога (при его отсутствии реаниматолога).

3.3 Исследования крови и мочи

Показаны всем пациентам с признаками ожога

1. развёрнутый общий анализ крови, общий анализ мочи;
2. биохимический анализ крови: билирубин и его фракции, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза, натрий, калий, хлориды, кальций.

При нефропатии, гепатопатии и почечно-печёночной недостаточности дополнительно определяют амилазу, щелочную фосфатазу, гамма-глутамилтрансферазу, общий белок и альбумин.

При отравлении уксусной кислотой определяют свободный гемоглобин в плазме и моче.

Степень гемолиза

1. лёгкая: **5 г/л**;
2. средняя: 5–10 г/л;
3. тяжёлая: **более 10 г/л**.

3.4 Эзофагогастродуоденоскопия

Показания

1. все пациенты с клиническими признаками ожога: оценка распространённости и глубины поражения, как правило **в первые 12–48 часов** (исследование безопасно до 96 часов);
2. дисковая батарейка или кристаллы перманганата калия: ЭГДС **экстренно**.

При минимальных проявлениях ЭГДС выполняют в ближайшее время, при тяжёлом состоянии после стабилизации. На 5–15-е сутки эндоскопия опасна перфорацией истончённой стенки. Экстренная эндоскопия необходима, если выполнить КТ невозможно (нет аппарата, противопоказано контрастирование, ребёнок, сомнительные данные КТ).

> В алгоритме ведения пациента (приложение Б) первичная ЭГДС указана «в первые 72 часа», тогда как в разделе 2.4 рекомендован срок 12–48 часов с безопасностью исследования до 96 часов.

Противопоказания к диагностической ЭГДС (до стабилизации состояния)

1. нестабильная гемодинамика;
2. рентгенологические признаки перфорации пищевода и медиастинита;
3. ожог надгортанника с отёком, ожог гортани и глотки III степени;
4. ожог дыхательных путей, требующий интубации или трахеостомии.

Ожог надгортанника, гортани и глотки грозит асфиксией из-за отёка голосовых складок, особенно при ожоге кристаллами перманганата калия.

При болевом синдроме в острой фазе перед эндоскопией вводят анальгетики и спазмолитики (папаверин и его производные).

Степень ожога и прогноз оценивают по классификации Zargar.

В первые сутки при ожоге I–II степени на слизистой оболочке видны белесоватые коагуляционные плёнки по рельефу складок; некроз тёмно-коричневый или чёрный; при отторжении струпа (3–4-е сутки) видны тёмно-красные грануляции.

В качестве альтернативы может применяться эндоскопическая классификация Волкова (1997) в дополнении Песни-Прасоловой (2006).

Контрольная ЭГДС

При ожоге I степени, стабильном состоянии и отсутствии жалоб контрольная ЭГДС **не рекомендуется**.

При ожоге II–III степени, стабильном состоянии и отсутствии жалоб контрольную ЭГДС выполняют **через 4–6 недель**.

В стадии грануляций и рубцов ЭГДС выполняют **через 3 недели** после травмы для оценки локализации и протяжённости стеноза и определения показаний к бужированию, баллонной дилатации и стентированию.

Эндоскопическая классификация рубцовых стенозов пищевода (Галлингер, 2000)

Степень	Просвет в зоне сужения
I	9–11 мм, проходит среднекалиберный гастроскоп
II	6–8 мм, проходит бронхофиброскоп 5,5–7 мм
III	3–5 мм, проходит ультратонкий эндоскоп 2,4–2,8 мм
IV	1–2 мм или просвета нет, проходит только струна

При дисфагии исследование начинают со среднекалиберного эндоскопа, чтобы не пропустить рубцы ротоглотки и входа в пищевод, затем используют малокалиберные эндоскопы. При подозрении на рак выполняется биопсия.

3.5 Рентгенологическое исследование

Обзорная рентгенография грудной клетки и брюшной полости выявляет перфорацию.

Диагностические признаки

1. воздух в средостении: перфорация пищевода;
2. воздух под диафрагмой: перфорация желудка.

Рентгеноконтрастное исследование пищевода позволяет оценить распространённость и глубину поражения пищевода и желудка. При перфорации применяют водорастворимый йодсодержащий контраст, при поздних исследованиях бария сульфат.

Диагностические признаки

1. I степень: глотание свободное, просвет обычный, складки местами утолщены до 5 мм, перистальтика сохранена;
2. II степень: глотание болезненное, просвет сужен, складки сглажены, стенка неэластична и не перистальтирует, спазмы, регургитация;
3. III–IV степень: глотание резко болезненное, просвет расширен до 4–6 см и содержит жидкость, атония, рельеф отсутствует, плоские ниши.

В стадии рубцов выполняют рентгенографию пищевода с обязательным исследованием желудка и двенадцатиперстной кишки: определяют локализацию, протяжённость и диаметр стриктур. При непроходимости пищевода или свище используют водорастворимый контраст.

При экзотоксическом шоке, нарушении глотания и проходимости пищевода контрастное исследование **не рекомендуется** из-за угрозы аспирации.

3.6 Компьютерная томография

Показания

1. пациенты **18 лет и старше**: экстренная КТ грудной и брюшной полости с внутривенным контрастированием при сохранной функции почек для оценки локализации, объёма и глубины поражения.

КТ точнее ранней эндоскопии оценивает трансмуральный некроз; решение об экстренной экстирпации пищевода основывают на КТ-признаках трансмурального некроза.

Прогноз по данным КТ

1. I степень: осложнения маловероятны;
2. II степень: возможна стриктура;
3. III степень: стриктура неизбежна;
4. IV степень: трансмуральное поражение, высокий риск перфорации, показана неотложная эзофагэктомия.

Эндоскопию в первые 12–48 часов КТ полностью не заменяет.

Детям рутинная КТ не рекомендуется (нет данных об эффективности, лучевая нагрузка); исследование полезно при обширном поражении перед операцией.

3.7 Диагностическая лапароскопия

Показания

1. высокий риск перфорации желудка по данным эндоскопии: исключение перитонита.

4. Лечение

4.1 Догоспитальный этап

На догоспитальном этапе необходимо подтвердить приём вещества, определить вещество, причину и время приёма.

Не рекомендуются

1. положение пациента лёжа на спине;
2. приём разбавителей;
3. нейтрализация вещества.

Эти меры вызывают повторный ожог и аспирацию. Лечение поздних последствий проводится в специализированных центрах.

4.2 Острая стадия: неотложная помощь

Показано немедленное комплексное лечение: обезболивание, промывание желудка через зонд, местное лечение, детоксикация с коррекцией нарушений функций органов. При ожоге кристаллами перманганата калия применяют растворы слабых кислот (аскорбиновая кислота).

Обезболивание у взрослых

1. опиоиды (морфин, тримеперидин, кодеин + морфин + носкапин + папаверин + тебаин) или кеторолак, метамизол натрия по 1 мл 3–4 раза в сутки;
2. атропин 0,1% 1 мл 2 раза в сутки;
3. папаверин 2% 2 мл, дротаверин 2 мл в/м или платифиллин 0,2% 1 мл подкожно до 4 раз в сутки;
4. глюкозоновокаиновая смесь (500 мл 5% декстрозы и 50 мл 2% прокаина) в/в 2–3 раза в сутки.

Промывание желудка без зонда с вызыванием рвоты **не рекомендуется**: возможны повторный ожог пищевода и аспирация. Промывание через зонд эффективно и безопасно **в первые 2–3 часа**, через 12 часов неэффективно.

Применение нейтрализаторов при оказании неотложной помощи **не рекомендуется**.

Дыхательные пути

При нарастании отёка дыхательных путей и угрозе асфиксии выполняется интубация трахеи; при невозможности интубации накладывается временная трахеостома.

При компенсированном стенозе гортани показаны глюкокортикоиды внутривенно и ингаляционно, атропин внутривенно.

Глюкокортикоиды по степени ожога

1. I степень: не назначаются;
2. II–III степень: коротким курсом **5–7 дней**.

Инфузионная терапия при экзотоксическом шоке

1. в первые часы: сбалансированные электролитные растворы, в дальнейшем растворы декстрозы;
2. при отсутствии эффекта кристаллоидов: альбумин 5% или 10%;
3. в первые 6 часов для уменьшения ацидоза: меглюмина натрия сукцинат 1,5%;
4. при прогрессирующей сердечной недостаточности: инотропная поддержка, предпочтительнее добутамин;
5. коррекция ацидоза: 4% натрия гидрокарбонат внутривенно;
6. оптимальный темп диуреза: 0,5–1,0 мл/кг/ч.

Растворы гидроксиэтилкрахмала противопоказаны из-за риска почечного повреждения.

При декомпенсированном шоке коллоидные растворы вводят быстро струйно; интенсивная инфузия продолжается до повышения гемодинамических показателей на 45–50% от исходного уровня.

4.3 Острая стадия: кровотечения, инфекция, питание

При ранних вторичных кровотечениях выполняется местный гемостаз (наилучший эффект даёт локальная гипотермия пищевода и желудка); гепарин натрия вводится только после локальной остановки кровотечения.

При поздних кровотечениях гепарин **не рекомендуется**; проводится стандартная гемостатическая терапия: голод, переливание эритроцитов, плазмы, фибриногена.

При поздних кровотечениях применяют эндоскопический гемостаз (электро- или лазерную коагуляцию).

Для профилактики поздних кровотечений назначают ингибиторы протонного насоса и антациды.

Взрослым для лечения токсической коагулопатии и профилактики микротромбообразования назначают антикоагулянты под контролем показателей свёртывания, фибриногена и числа тромбоцитов.

Для профилактики инфекционных осложнений назначают антибактериальные препараты широкого спектра действия, затем терапию корректируют по результатам посева.

Ранняя нутритивная поддержка начинается **в первые 12 часов**.

1. пища механически, термически и химически щадящая;
2. при недостаточном энтеральном питании дополнительно назначается парентеральное;
3. при невозможности энтерального питания решается вопрос о гастростоме.

Назначают ингибиторы протонного насоса (в остром периоде внутривенно), облепиховое масло, антациды.

Глюкокортикоиды для профилактики рубцового сужения

1. лёгкий ожог: в стационаре **7 суток**, затем амбулаторно **3 недели**;
2. ожог средней тяжести: **до 20 суток**, затем **1 месяц**;
3. тяжёлый ожог: **не менее 30 суток**, затем **до 2 месяцев**.

4.4 Острая стадия: перфорация

При перфорации пищевода или желудка проводятся экстренные мероприятия с учётом локализации, размера перфорации и осложнений; тактику определяют по данным рентгеноскопии с водорастворимым контрастом и (или) КТ.

1. без медиастинита: кормление через рот исключают, устанавливают назогастральный зонд, назначают парентеральное питание и антибиотики (цефалоспорины, метронидазол, защищённые пенициллины), иногда выполняют гастростомию;
2. медиастинит: экстренная операция торакотомным или торакоскопическим доступом с санацией и дренированием средостения, гастростомией и антирефлюксной операцией; возможна эндоскопическая вакуумная терапия;
3. необратимые изменения пищевода: эзофагэктомия с эзофаго- и гастростомией; у взрослых эзофагогастрэктомия, летальность 25–34%.

Если некроз ограничен желудком, следует рассмотреть гастрэктомию с сохранением пищевода; резекции желудка целесообразно избегать, поскольку продолжающийся некроз может ухудшить исход.

4.5 Формирующиеся стриктуры (до 4 недель)

При выраженной дисфагии и быстро формирующихся рубцах показано профилактическое бужирование пищевода.

Применяют бужи не меньше возрастного размера пищевода, в стационаре **3 раза в неделю** по струне-проводнику, затем прямое бужирование; через 3 недели выполняется ЭГДС. При полной эпителизации бужирование прекращают, контроль через 2–3 месяца. При ожоге III степени бужирование проводят 3 недели по 3 раза в неделю, затем амбулаторно 1 раз в неделю 2–3 месяца, 2 раза в месяц 2–3 месяца, 1 раз в месяц полгода; ЭГДС каждые 3 месяца.

4.6 Сформированные стриктуры

Дилатацию стеноза пищевода начинают **через 4–6 недель** после ожога с бужирования по струне-проводнику.

При стриктуре, нарушающей питание, проводится поддерживающее бужирование **12 месяцев**; при стойкой положительной динамике срок может быть увеличен, но не более **24 месяцев**. При неэффективности пересматривают программу бужирования или решают вопрос о реконструктивной операции.

Бужирование по струне-проводнику выполняют под эндотрахеальным наркозом: не более 3 бужей за сеанс, повтор через 2–3 дня, затем бужирование «вслепую» и амбулаторно 1 раз в неделю 3 месяца. Бужирование прекращают при полной эпителизации и просвете **не менее 10–12 мм**. При протяжённых стриктурах после ожога щелочами и кислотами и при ожоге гортаноглотки перманганатом калия у детей применяют бужирование за нить через гастростому (у детей при ожоге глотки используют бужи № 44–60).

Размеры бужей по шкале Шарьера

Возраст	Размер бужа, Fr
до 6 месяцев	33–36
до 1 года	36–40
1–3 года	40–42
4–7 лет	42–44
8–17 лет	44–46

Критерии неэффективности бужирования

1. не достигается максимальный размер бужа;
2. дисфагия или стеноз возвращаются между бужированиями;
3. не удаётся перейти на более редкое бужирование;
4. после курса нарастает дисфагия.

Критерии хорошего результата

1. любая пища проходит без дисфагии;
2. поддерживающее бужирование не требуется;
3. просвет в зоне стеноза **не менее 10–12 мм**.

При стриктуре протяжённостью **до 5 см** альтернативой является гидростатическая баллонная дилатация под рентгеноскопическим контролем и общей анестезией.

Стентирование при формирующихся стриктурах **не рекомендуется**: положительных результатов нет, осложнения частые.

4.7 Реконструктивные операции

Показания к операции при послеожоговых стриктурах

1. полная облитерация просвета;
2. извилистый просвет со слепыми карманами и дивертикулами;
3. невозможность провести буж № 28–30 из-за плотных рецидивирующих стриктур;
4. пищеводные свищи;
5. перфорация пищевода в анамнезе;
6. давность рубцов **более 15 лет** (риск малигнизации);
7. укорочение пищевода с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагитом.

При изолированном рубцовом стенозе глотки выполняется пластика глотки свободным сегментом кишки.

Изолированные стенозы глотки в 100% случаев вызваны ожогом кристаллами марганца: рубцуются вход в глотку и вход в гортань (надгортанник лизируется), пациенты выживают только при экстренной трахеостомии и живут с трахео- и гастростомой. Трансплантат реваскуляризируют с общей сонной артерией и внутренней яремной веной.

При стенозе глотки и шейного отдела пищевода выполняется пластика свободным сегментом кишки; при субтотальном поражении глотки и пищевода показана пластика пищевода толстой кишкой.

При протяжённых или множественных стриктурах выполняется пластика пищевода с одномоментной или раздельной экстирпацией; метод выбирают хирурги специализированных центров.

Детям с протяжёнными или множественными стенозами выполняется колоэзофагопластика с загрудинным проведением трансплантата.

При протяжённых стриктурах без ожога желудка выполняется резекция пищевода абдоминоцервикальным доступом с пластикой желудком.

При стенозе привратника выполняется операция (задний гастроэнтероанастомоз с анастомозом по Брауну; резекция желудка не рекомендуется) или эндоскопическая баллонная дилатация.

При трахеопищеводном соустье без дыхательной недостаточности придерживаются сдерживающей тактики: лапароскопическая фундопликация, гастростомия, консервативная терапия; свищ закрывается в среднем **до 5 месяцев**.

Детям с большим соустьем и дыхательной недостаточностью выполняется пластика трахеи пищеводным лоскутом с экстирпацией пищевода, пластика пищевода выполняется позже в плановом порядке.

Аортопищеводная фистула требует экстренной операции даже без видимого кровотечения.

Триада Киари

1. нарастающая загрудинная боль;
2. необильные периодические кровотечения;
3. массивное кровотечение после «светлого промежутка».

При кровотечении устанавливают зонд Блэкмора (пищеводный баллон на уровень средней трети пищевода); клипирование ошибочно.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. клинико-анамнестические признаки химического ожога ЖКТ.

Критерии выписки

1. нормализация общего состояния и лабораторных показателей;
2. отсутствие эрозивно-язвенного эзофагита при эндоскопии;
3. отсутствие осложнений;
4. нормальный нутритивный статус, возможность энтерального питания (естественного или через гастростому).

При ожоге I степени пациента начинают кормить незамедлительно и выписывают через **24–48 часов**, поскольку риска стриктуры нет.

После приёма вещества с суицидальной целью перед выпиской показан осмотр психотерапевта, целесообразно долгосрочное наблюдение.

Контроль психического состояния и психологическая поддержка обязательны перед выпиской у всех пациентов независимо от тяжести ожога.

5.2 Медицинская реабилитация

Реабилитацию начинают как можно раньше, одновременно с лечением.

Методы

1. индуктотермия;
2. цинк-электрофорез;
3. электрофорез органно-минерального комплекса;
4. низкоинтенсивное лазерное излучение;
5. после бужирования: магнитотерапия курсами 5–7 сеансов.

5.3 Диспансерное наблюдение

После выписки пациент наблюдается у хирурга (детского хирурга) поликлиники в течение **3 лет** от момента травмы.

При ожоге III степени показана плановая госпитализация для ЭГДС **через 1 месяц** после выписки, затем через 3 и 6 месяцев.

1. нет признаков стриктуры: осмотр хирурга **каждые 6 месяцев**, всего **в течение 3 лет**;
2. появилась дисфагия: госпитализация для ЭГДС;
3. рубцовая деформация без сужения: ЭГДС **каждые 3 года** в связи с риском малигнизации.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Химический ожог пищевода»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 25.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	`821_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Российская ассоциация детских хирургов; Российское общество хирургов; Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов; Национальное общество торакальных хирургов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки глюкокортикоидов расходятся: при стенозе гортани ожог I степени не требует глюкокортикоидов, при II–III степени курс 5–7 дней; для профилактики рубцового сужения курс от 7 суток (лёгкий ожог) до не менее 30 суток (тяжёлый) с продолжением амбулаторно.
- Срок первичной ЭГДС: в разделе 2.4 рекомендованы первые 12–48 часов (исследование безопасно до 96 часов), в алгоритме ведения пациента (приложение Б) указаны «первые 72 часа».
- Таблица Zargar в разделе 1.5 и в приложении А3 различается: степень IIB описана как «глубокие и циркулярные язвы» и «окружные поражения».

Клинические рекомендации

Хронический ринит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J30.0** — Вазомоторный ринит **J31.0** — Хронический ринит **J34.3** — Гипертрофия носовой раковины
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 06.10.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Национальная ассоциация ринохирургов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1082_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Хронический ринит (ХР): воспаление слизистой носа с двумя и более симптомами — заложенность, выделения, чихание, зуд — **не менее 1 часа** ежедневно **не менее 12 недель** в год. Кроме атрофического, это «диагноз второй очереди»: он устанавливается после исключения инфекционной и аллергической природы ринита.
- Лечение: устранить причину и триггеры, промывания солевыми растворами. Вазомоторный ринит: назальные кортикостероиды или азеластин **с 12 лет**. Медикаментозный ринит: постепенная отмена деконгестанта на фоне других средств.
- Деконгестанты — **не более 7 дней**, при хронических заболеваниях носа и пазух лучше **не более 3 дней**.
- Операция — симптоматическое лечение: при неэффективности адекватной терапии **6–12 месяцев** или при гипертрофическом рините. Турбинэктомия (радикальная конхотомия) не рекомендуется, кроме тяжёлых форм первичного атрофического ринита.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический ринит: любое воспаление слизистой оболочки носа с двумя и более симптомами — заложенность, ринорея, чихание, зуд в носу — **не менее 1 часа** ежедневно **не менее 12 недель** в год. Обычно так называют все хронические риниты, кроме аллергического (неаллергический ринит).

2.2 Фенотипы

Фенотипы хронического ринита

Фенотип	Определение
Вазомоторный (идиопатический) ринит, неаллергическая ринопатия	самый частый фенотип; диагноз после исключения инфекции, аллергии и других форм ХР; в основе — нарушение нервно-рефлекторной регуляции микроциркуляции слизистой
Гипертрофический ринит (гипертрофия нижних носовых раковин)	необратимое увеличение нижних раковин как проявление ХР, реже за счёт костной основы; стойкое затруднение носового дыхания
Гормональный ринит	при гипотиреозе или изменении уровня половых гормонов: беременность, менопауза, фазы цикла, пубертат
Ринит беременных (гестационный)	стойкая заложенность, возникшая во время беременности (чаще во II–III триместре), 6 недель и более, без инфекции и аллергии, проходит за 2 недели после родов
Лекарственно-индуцированный ринит	изменения слизистой от системных и назальных лекарственных препаратов
Медикаментозный ринит	самый частый лекарственно-индуцированный: длительное применение назальных деконгестантов
Профессиональный ринит	назальные симптомы, связанные с рабочей средой; неаллергический — от низкомолекулярных раздражителей (менее 5 кДа), высокомолекулярные чаще вызывают аллергический
Ринит курильщика	разновидность профессионального: раздражитель — табачный дым

Фенотип	Определение
Вкусовой ринит	водянистая ринорея на острую пищу или алкоголь, без чихания, зуда, кожных симптомов и бронхообструкции
Ринит пожилых (старческий)	старше 65 лет; водянистая ринорея, усиливается от триггеров; иногда сухость и корки
Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом (NARES)	эозинофильное воспаление слизистой при отрицательных аллергопробах
Атрофический ринит	атрофия слизистой: заложенность, сухость, корки, носовые кровотечения; первичный и вторичный
Хронический катаральный ринит	по морфологической классификации Л. Б. Дайняка (1966): постоянное негнойное воспаление; используется при смешанных фенотипах

По течению

1. интермиттирующий: симптомы **менее 4 дней** в неделю или **менее 4 недель** в году;
2. персистирующий: **более 4 дней** в неделю и **более 4 недель** в году.

По тяжести

1. лёгкая: слабые симптомы, не нарушают дневную активность и сон;
2. средняя: мешают работе, учёбе, спорту, нарушают сон;
3. тяжёлая: значительно ухудшают качество жизни, без лечения нормальная жизнь невозможна, значительно нарушен сон.

У взрослых и подростков — 10-балльная ВАШ: **менее 5 баллов** — лёгкое течение, **5 и более** — среднетяжёлое или тяжёлое. Около 20% пациентов — смешанные или неклассифицируемые формы.

2.3 Этиология

Выделяют воспалительный эндотип (воспаление слизистой) и нейрогенный (нарушение вегетативной регуляции тонуса сосудов и секреции).

Общее для всех форм, кроме атрофического, — гиперреактивность слизистой к неспецифическим триггерам, слабее, чем при аллергическом рините.

Препараты, вызывающие лекарственно-индуцированный ринит

Группа препаратов	Препараты
Нестероидные противовоспалительные (M01A)	диклофенак, кеторолак, целекоксиб
Альфа-адреноблокаторы (G04CA, C02CA)	алфузозин, доксазозин, силодозин, тамсулозин
Антиадренергические центрального действия (C02A)	клонидин, метилдопа
Агонисты дофаминовых рецепторов (N04BC)	пирибедил
Бета-адреноблокаторы (C07A)	атенолол, бисопролол, карведилол, метопролол, пропранолол

Группа препаратов	Препараты
Противоопухолевые (L01)	анагрелид
Антитромботические (B01)	цилостазол, дипиридамол
Для лечения эректильной дисфункции (G04BE)	силденафил, тадалафил, варденафил
Ингибиторы АПФ (C09A)	каптоприл, эналаприл, лизиноприл, рамиприл
Психолептики (N05) и психоаналептики (N06)	алпразолам, амитриптилин, хлорпромазин, миансерин, рисперидон, тиоридазин; гинкго билоба листья
Ингибиторы кальциневрина (L04AD)	циклоспорин
Эстрогены (G03C)	—
Диуретики (C03)	гидрохлоротиазид
Противоэпилептические (N03A)	габапентин

Вещества, вызывающие профессиональный ринит

Вещество	Профессия, категория населения
Высокомолекулярные (более 5 кДа), аллергический ринит: зерновая мука; эпидермис животных; латекс	пекари, пищевая промышленность; лаборатории, животноводство, скотобойни, ветеринары; медработники, лаборатории, клининг
Низкомолекулярные (менее 5 кДа), неаллергический ринит: персульфаты; древесная пыль; формальдегиды; выхлопные газы; бензол, толуол; тальк; аммиак, растворители; табачный дым	парикмахеры; столяры, деревообработка; строители, химпром, лаборатории, морги; автомеханики, дорожные рабочие, жители мегаполисов; маляры; косметическая промышленность, лаборатории, медработники; химпром, лаборатории; курящие и их окружение

Первичный атрофический ринит обычно у людей старше 50 лет, чаще у отдельных этнических групп (юг Азии, Африка); вторично присоединяется Klebsiella ozaenae. Вторичный атрофический ринит развивается чаще после ринохирургии (прежде всего на нижних раковинах), реже от назальных препаратов, лучевой терапии, при гранулематозе с полиангиитом.

2.4 Клиническая картина

Выраженность симптомов по фенотипам

Фенотип	Заложенность	Ринорея	Зуд, чихание	Гипосмия
Старческий	++	+++	+	++
Профессиональный	++	+	++	+

Фенотип	Заложенность	Ринорея	Зуд, чихание	Гипосмия
Медикаментозный, лекарственно-индуцированный	+++	+	+	+
Гормональный	++	++	+	+
Вкусовой	++	+++	+	+
Вазомоторный	++	++	++	++
NARES	++	++	+	+++

Патогномоничных симптомов нет.

Общие симптомы, кроме атрофического ринита

1. заложенность носа;
2. передняя и задняя ринорея;
3. чихание, зуд;
4. гипосмия.

Глазных симптомов, в отличие от аллергического ринита, нет; триггеры действуют слабее.

Течение

1. постоянные симптомы: старческий ринит, NARES, медикаментозный, тяжёлый профессиональный;
2. только при воздействии причины: лёгкий профессиональный, вкусовой;
3. волнообразное: вазомоторный и гормональный;
4. лекарственно-индуцированный: зависит от схемы и длительности приёма препарата.

Атрофический ринит

1. сухость и раздражение в носу, корки, носовые кровотечения;
2. заложенность и снижение обоняния;
3. при тяжёлом течении — полное отсутствие носового дыхания, не восстанавливающееся после деконгестантов, и аносмия.

Наиболее тяжело протекают первичный атрофический ринит и вторичный, связанный с системными аутоиммунными гранулематозными полиангиитами: поражаются хрящевые и костные структуры вплоть до перфорации перегородки носа, изменения формы наружного носа и секвестрации раковин.

Первичный атрофический ринит у детей встречается крайне редко; вторичный у детей бывает чаще первичного, но реже, чем у взрослых.

---

3. Диагностика

Чётких общих критериев нет. Формула фенотипа: периодические или постоянные симптомы ринита + связь с определённым внешним или внутренним фактором (после исключения инфекции и аллергии).

Смешанные формы ринитов существуют: признаки инфекции или аллергии не исключают у пациента фенотип ХР.

Критерии диагноза по фенотипам

Фенотип	Критерии диагноза
Ринит беременных	1. заложенность носа, которой не было до беременности; 2. симптомы 6 недель и более; 3. исключены аллергия и инфекция; 4. полное разрешение за 2 недели после родов (ретроспективно).
Медикаментозный	1. регулярное ежедневное применение назальных сосудосуживающих вне простуд для улучшения дыхания.
Лекарственно-индуцированный	1. симптомы (прежде всего заложенность) вне простуд на фоне некоторых классов препаратов, проходят по окончании их действия.
Профессиональный	1. симптомы на рабочем месте или их усиление на работе; 2. уменьшаются или проходят вне работы; 3. исключён аллергический ринит.
Ринит пожилых	1. постоянные (чаще слизистые) выделения или стекание по задней стенке глотки; 2. старше 65 лет; 3. исключены аллергия и другие причины ринореи.
Вкусовой	1. симптомы на пряную пищу, проходят после её прекращения; 2. исключён аллергический ринит; 3. нет симптомов в начале приёма пищи.
NARES	1. эозинофилы более 25% в цитологии мазка со слизистой носа; 2. исключён аллергический ринит; 3. персистирующие симптомы с выраженным нарушением обоняния.
Вазомоторный	1. периодические или постоянные симптомы без связи с внешними и внутренними факторами; у взрослых чаще попеременная заложенность половин носа, заложенность на стороне, на которой лежит; 2. исключён аллергический ринит; 3. исключены другие причины по осмотру оториноларинголога.
Гормональный	1. общепринятых критериев нет: подтверждённый гипотиреоз или акромегалия с персистирующими симптомами, либо симптомы при менструации, в пубертате — после исключения других причин.
Атрофический	1. признаки атрофии: корки, сухость слизистой; 2. ощущение сухости, заложенность, нарушение обоняния или неприятный запах выделений; 3. и (или) периодические носовые кровотечения.

3.1 Жалобы, анамнез и осмотр

Уточняют

1. длительность, что спровоцировало начало, динамику жалоб, влияние на сон и активность;
2. лечение и его эффект, нежелательные явления;
3. симптомы вне эпизодов ОРИ;
4. сопутствующие заболевания, прежде всего аллергию;
5. ринохирургические вмешательства и манипуляции в носу.

Всем пациентам с ХР показан первичный осмотр оториноларинголога.

3.2 Цитологическое исследование мазка из носа

Показания

1. подростки и взрослые с персистирующими симптомами и выраженным нарушением обоняния при исключённом аллергическом рините: подтверждение или исключение NARES.

Для остальных фенотипов рутинно не проводят: низкие чувствительность и специфичность.

3.3 Посев отделяемого из носа

Показания

1. признаки первичного атрофического ринита: выявление Klebsiella ozaenae.

3.4 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Показания

1. стойкая выраженная одно- или двусторонняя назальная обструкция: оценка полости носа и дифференциальная диагностика.

3.5 КТ или конусно-лучевая томография пазух

Показания

1. подозрение на сопутствующий хронический риносинусит.

Конусно-лучевая томография — вариант КТ с меньшей лучевой нагрузкой.

3.6 Консультации специалистов

Показания к консультации аллерголога-иммунолога

1. все фенотипы, кроме атрофического ринита: подтверждение или исключение аллергического ринита.

При аллергическом рините сопутствующий фенотип ХР выделяют, если сенсибилизация не объясняет течение (например, круглый год при сенсибилизации только к пыльце) или нет контроля при максимальном лечении.

Показания к консультации эндокринолога

1. взрослые с ХР без диагностированной эндокринной патологии, но с признаками гипотиреоза.

Признаки гипотиреоза

1. утомляемость, сонливость;
2. сухость кожи, выпадение волос;
3. замедленная речь, охриплость;
4. отёчность лица, пальцев;
5. запоры, зябкость, снижение памяти, подавленность.

Показания к консультации детского эндокринолога

1. дети с ХР после исключения аллергического и медикаментозного ринита, с признаками врождённого гипотиреоза;
2. девочки пубертатного возраста с ХР после исключения аденоидов, аденоидита, аллергического и медикаментозного ринита.

Показания к консультации профпатолога

1. взрослые с подозрением на профессиональный ринит: установление связи с производственной средой.

4. Лечение

Ключевым направлением лечения является устранение или минимизация влияния причинного фактора, если его удаётся установить.

За исключением гипертрофической формы хронический ринит изначально не требует операции, а необоснованное вмешательство нередко вредит. Операция остаётся лишь симптоматическим методом: она может улучшить носовое дыхание, но почти не влияет на ринорею, чихание, зуд и обоняние.

Все формы хронического ринита, кроме некоторых видов атрофического, не угрожают жизни и не создают высокого риска тяжёлых осложнений. Поэтому консервативное лечение проводят планово и амбулаторно, а операцию выполняют планово в условиях стационара.

4.1 Базисная терапия

Показания к лечебно-оздоровительному режиму

1. всем пациентам — ограничение причинных факторов и триггеров.

Триггеры

1. табачный дым и пар электронных сигарет;
2. перепады температуры, запылённость, резкие запахи;
3. пряности, алкоголь;
4. нарушение сна, гиподинамия, стресс.

Показания к ирригационной терапии

1. все фенотипы хронического ринита, в том числе ринит беременных: промывание или орошение носа морской водой, стерильными солевыми растворами.

Способ, кратность, изо- или гипертонический раствор и длительность выбирает врач по фенотипу и течению.

4.2 Вазомоторный ринит

Показания к назальным кортикостероидам

1. вазомоторный ринит у пациентов **старше 12 лет**.

Дозы

1. беклометазон: 200–400 мкг в сутки, курс **не более 3 месяцев**;
2. #мометазон: 200 мкг 1 раз в день, **6 недель**;
3. #флутиказон: 200 мкг 1 раз в день, **3 месяца**.

Минимальная эффективная доза; предупредить о носовых кровотечениях. Не применять при атрофии слизистой, в том числе при атрофическом рините.

Азеластин назально назначают курсом **2–3 недели** пациентам **старше 12 лет** с вазомоторным ринитом. Данных о пользе более длительного курса нет.

Показания к фиксированным комбинациям

1. смешанные фенотипы с сопутствующим аллергическим ринитом.

Препараты и возрастные ограничения

1. азеластин + флутиказон, мометазон + олопатадин: **старше 12 лет**;
2. азеластин + мометазон: **старше 18 лет**.

4.3 Обострение и медикаментозный ринит

При обострении с выраженной заложенностью назначают оксиметазолин коротким курсом **до 7 дней**. Деконгестанты уменьшают только заложенность. Предпочтительны назальные препараты без антисептиков-консервантов.

Показания к сочетанию оксиметазолина с #мометазоном

1. взрослые, которым деконгестант нужен дольше недели при обострении ХР или острой инфекции носа с выраженной заложенностью.

Схема

1. оксиметазолин спрей вместе с #мометазоном 100–200 мкг в сутки, **15–20 дней**.

Медикаментозный ринит: деконгестант отменяют постепенно, сначала уменьшая кратность и разовую дозу, одновременно назначают морскую воду, назальные кортикостероиды, противоаллергические средства. Требование одномоментной отмены часто не выполняется.

4.4 Атрофический и хронический катаральный ринит

При атрофическом рините назначают увлажняющие средства на основе натрия гиалуроната.

При тяжёлом первичном атрофическом рините с выделением Klebsiella ozaenae назначают системные антибиотики с учётом чувствительности возбудителя.

Пациентам **старше 18 лет** с хроническим катаральным ринитом и гнойным отделяемым назначают фрамицетин.

Пациентам **старше 18 лет** с хроническим катаральным ринитом и вязким секретом назначают назальный спрей ацетилцистеин + туаминогептан.

Пациентам с вазомоторным, медикаментозным или лёгким атрофическим ринитом, приверженным такому лечению, возможно назначение гомеопатических средств, зарегистрированных в России как лекарственные препараты, по показаниям инструкции.

При вазомоторном или медикаментозном рините с ограничениями медикаментозного лечения показана консультация физиотерапевта.

4.5 Хирургическое лечение

Хирургическое лечение по фенотипам

1. при гипертрофическом рините операция проводится всем пациентам;
2. при вазомоторном, медикаментозном рините и NARES — при наличии обоснования, при старческом, профессиональном и атрофическом — в редких случаях;
3. при гормональном, гестационном, вкусовом и лекарственно-индуцированном рините данных о пользе хирургического лечения нет.

Показание

1. адекватное лечение **6–12 месяцев** не улучшило качество жизни или операция может значительно его улучшить.

Принцип минимальной травматизации слизистой; пациента предупреждают о возможной нестойкости результата и повторных вмешательствах.

Показания к подслизистой вазотомии или пластике нижних носовых раковин

1. гипертрофический, вазомоторный, медикаментозный ринит или NARES, рефрактерные к лечению.

Вмешательство выполняют под эндоскопическим контролем.

У дошкольников и младших школьников чаще консервативный подход; у детей все манипуляции на раковинах — только в подслизистом слое.

Варианты: передняя и (или) задняя конхотомия, пластика раковин, подслизистая вазотомия, в том числе с латерализацией костной части; лазерные технологии. Сохранение слизистой уменьшает нарушения мукоцилиарного клиренса, синехии и корки.

Показания к селективной нейрэктомии нижней задней носовой ветви большого нёбного нерва

1. тяжёлое, медикаментозно неконтролируемое течение.

При выраженной заложенности нейрэктомию сочетают с операцией на раковинах. При атрофическом рините она не показана.

Показания к остеоконхотомии

1. гипертрофический ринит с увеличенным костным остовом нижней раковины.

Турбинэктомия (радикальная конхотомия) не рекомендуется, кроме тяжёлого первичного атрофического ринита.

Последствия турбинэктомии

1. нарушение воздушного потока;
2. корки, инфицирование;
3. риск синдрома «пустого носа».

Показания к резекции поражённых структур латеральной стенки по типу секвестрэктомии

1. тяжёлый первичный атрофический ринит.

Вмешательство паллиативное, облегчает уход.

Показания к пластике нижних раковин по типу аугментации нижнего носового хода

1. тяжёлый ятрогенный атрофический ринит с синдромом «пустого носа».

4.6 Лечение после вмешательства на нижних носовых раковинах

1. ранний и поздний послеоперационный период: промывание или орошение изотонической морской водой, солевыми растворами;
2. взрослые с тяжёлым первичным атрофическим ринитом после хирургического лечения: системные антибиотики.

При субатрофических проявлениях после операции на раковинах назначают увлажняющие средства с натрия гиалуронатом: они облегчают туалет носа и ускоряют восстановление слизистой оболочки.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Диагностика и консервативное лечение проводятся амбулаторно, плановое хирургическое лечение — в стационаре.

Показания к плановой госпитализации для операции

1. вазомоторный и медикаментозный ринит (реже тяжёлый NARES, гормональный, профессиональный, сенильный) без эффекта адекватного лечения **6–12 месяцев**;
2. гипертрофический ринит с увеличенным костным остовом, постоянной выраженной заложенностью и значительным снижением качества жизни;
3. тяжёлый первичный атрофический ринит;
4. тяжёлый ятрогенный атрофический ринит с синдромом «пустого носа».

Выписка

1. хирургическое лечение выполнено в необходимом объёме;
2. удовлетворительное состояние, нет острого инфекционного воспаления.

5.2 Профилактика

Не применять назальные деконгестанты **более 7 дней**; при хронических воспалительных заболеваниях носа и пазух лучше ограничиться **3 днями**.

Профилактические меры

1. отказ от курения и электронных сигарет;
2. группа риска профессионального ринита: промывания изотоническими растворами и средства индивидуальной защиты;
3. вкусовой ринит в анамнезе: отказ от пряностей и (или) алкоголя;
4. при назначении препаратов, вызывающих ринит, предупредить пациента и при появлении симптомов решить вопрос об отмене или замене;
5. функциональный подход при операциях на нижних раковинах для профилактики ятрогенного атрофического ринита.

Специфической профилактики ринита беременных, гормонального, ринита пожилых, NARES и вазомоторного ринита нет. Медицинская реабилитация не показана.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический ринит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 06.10.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2029 года
Код в рубрикаторе	`1082_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Национальная ассоциация ринохирургов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Хронический синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J32.0** — Хронический верхнечелюстной синусит **J32.1** — Хронический фронтальный синусит **J32.2** — Хронический этмоидальный синусит **J32.3** — Хронический сфеноидальный синусит **J32.4** — Хронический пансинусит **J32.8** — Другие хронические синуситы **J32.9** — Хронический синусит неуточненный **J34.1** — Киста или мукоцеле носового синуса
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/955_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз хронического синусита у взрослых устанавливается при сохранении **двух симптомов и более** (обязательно заложенность носа или выделения из носа) **12 недель и более** и подтверждается эндоскопией или КТ (полные критерии во вкладке «Диагностика»).
- Основа консервативного лечения:
  1. промывание полости носа солевым раствором всем пациентам;
  2. интраназальные глюкокортикостероиды пациентам **старше 12 лет**; для оценки эффекта их применяют **не менее 3 месяцев**.
- К системной антибактериальной терапии прибегают только при среднетяжёлом и тяжёлом обострении или осложнениях; стартовый препарат в амбулаторной практике: амоксициллин с клавулановой кислотой.
- Взрослым при неэффективности **1–2 курсов** адекватной консервативной терапии показана функциональная риносинус-хирургия.
- Детям при неэффективности консервативной терапии **в течение 3–6 месяцев**:
  1. при гипертрофии аденоидов III степени первым этапом удаление аденоидов;
  2. при среднетяжёлом и тяжёлом ХРС, если гипертрофия аденоидов исключена или аденоиды удалены **более 6 месяцев** назад, функциональная эндоскопическая риносинус-хирургия.
- Показания к экстренной госпитализации в оториноларингологическое отделение:
  1. внутричерепные или внутриглазничные осложнения;
  2. тяжёлое обострение;
  3. среднетяжёлое обострение при неэффективности амбулаторного лечения **в течение 5–7 дней**;
  4. прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.
- При случайном выявлении бессимптомной кисты околоносовой пазухи большинство экспертов считают хирургическое вмешательство нецелесообразным, поскольку многие кисты медленно уменьшаются самостоятельно или не изменяются.
- Мукоцеле растёт медленно, растягивает, а в ряде случаев разрушает стенку пазухи. Консервативному лечению оно не поддаётся, поэтому при выявлении показано плановое хирургическое лечение.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический синусит (хронический риносинусит, ХРС) — это воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух длительностью **более 12 недель** с **двумя и более** симптомами.

Симптомы

1. заложенность носа или выделения из носа (передние или стекающие в носоглотку): один из них обязателен;
2. боль или ощущение давления в области лица;
3. снижение или потеря обоняния.

Определения кист околоносовых пазух

1. **Ретенционные (истинные, секретирующие) кисты** формируются в результате обструкции выводных протоков желёз слизистой оболочки; стенки таких кист имеют двустороннюю выстилку мерцательным цилиндрическим эпителием.
2. **Лимфоэктатические (несекретирующие, ложные, интрамуральные) кисты** — доброкачественные образования, расположенные в толще слизистой оболочки, без внутренней эпителиальной выстилки; они возникают вследствие хронического воспаления в околоносовых пазухах или баротравмы.

Мукоцеле представляет собой доброкачественное, медленно растущее кистовидное образование околоносовой пазухи. Оно формируется при стойком нарушении дренажной функции естественного соустья пазухи и часто вызывает растяжение, реже разрушение её стенок.

2.2 Этиология

Заболевания, ассоциированные с ХРС

1. аллергический ринит;
2. первичная цилиарная дискинезия;
3. муковисцидоз;
4. бронхиальная астма;
5. гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
6. иммунодефицитные состояния;
7. системные аутоиммунные заболевания.

Анатомические особенности остиомеатального комплекса

1. искривление перегородки носа;
2. буллёзная или парадоксально изогнутая средняя носовая раковина;
3. гиперпневматизация решётчатой буллы, супрабуллярной или инфраорбитальной клетки;
4. аномалии крючковидного отростка;
5. добавочное соустье верхнечелюстной пазухи.

Эти особенности нарушают вентиляцию полости носа и отток секрета из полости носа и околоносовых пазух. У детей, значительно реже у взрослых, ХРС может быть связан с гипертрофией аденоидов.

У детей, особенно дошкольного возраста, основной причиной ХРС является муковисцидоз, реже первичная цилиарная дискинезия. По данным отечественных исследований, связь между ХРС и искривлением перегородки носа у детей не выявлена.

Предрасполагающим фактором может являться также аллергический отёк слизистой оболочки в области среднего носового хода; аллергический ринит и хронический синусит часто сочетаются.

Одонтогенный синусит связан с заболеваниями зубов и стоматологическим лечением; среди возбудителей преобладают анаэробы.

Причины хронического верхнечелюстного синусита

1. периодонтит или пародонтит;
2. эндодонтическое лечение (частая причина): инфицированный детрит или пломбировочный материал попадает в пазуху через корневые каналы;
3. дентальная имплантация с предшествующим наращиванием костной ткани.

ГЭРБ также может способствовать развитию ХРС: попадание рефлюктата на слизистую оболочку полости носа и носоглотки вызывает воспаление и нарушение мукоцилиарного клиренса, что может привести к блоку остиомеатального комплекса.

Важным фактором риска является курение: табак оказывает токсическое действие на слизистую оболочку полости носа, вызывает её сухость и изменяет свойства слизи.

Связь ретенционных кист с воспалительными заболеваниями полости носа и травмами не доказана. Лимфоэктатические кисты в большинстве случаев обусловлены хроническим, прежде всего аллергическим, воспалением слизистой оболочки; риск их развития повышают гипервентиляция верхнечелюстной пазухи и баротравма. Радикулярная одонтогенная киста развивается из эпителиальной гранулёмы у верхушки корня кариозного зуба; зубная киста может оттеснять дно верхнечелюстной пазухи или прорастать в неё; фолликулярная киста развивается очень медленно из зубного фолликула.

В подавляющем большинстве случаев мукоцеле является следствием вмешательств на околоносовых пазухах.

Другие причины мукоцеле

1. травма;
2. хроническое воспаление пазух;
3. опухоли;
4. лучевая терапия.

Описаны врождённые мукоцеле. Более чем в трети случаев мукоцеле расценивается как идиопатическое, то есть причину установить не удаётся. У детей основной причиной является вторичный хронический синусит при муковисцидозе.

2.3 Классификация

По локализации (с указанием стороны)

1. верхнечелюстной;
2. этмоидальный;
3. фронтальный;
4. сфеноидальный.

Воспаление пазух только одной стороны обозначают как гемисинусит, поражение нескольких пазух как полисинусит.

В клинической практике хронический синусит принято подразделять на полипозный риносинусит и синусит без полипов.

По этиологии выделяют бактериальный, грибковый и бактериально-грибковый синусит.

Тяжесть оценивают по суммарной выраженности симптомов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10:

1. лёгкая форма: **0–3 балла**;
2. среднетяжёлая: **4–7 баллов**;
3. тяжёлая: **8–10 баллов**.

> Классификация по тяжести содержит ссылку на приложение Г1, однако в нём описана ВАШ только для оценки интенсивности боли и с другой градацией: значение до 2 см соответствует слабой боли, 2–4 умеренной, 4–6 сильной, 6–8 сильнейшей, до 10 невыносимой. Способ подсчёта суммарной выраженности симптомов в рекомендации не указан.

Классификация EPOS 2020 года основана на эндотипах и фенотипах. Первичный синусит может быть односторонним (локализованным), с воспалением 2-го типа или не 2-го типа; дополнительно выделяют аллергический грибковый синусит и изолированный синусит (название по поражённой пазухе). Первичный синусит может быть и двусторонним (диффузным) с теми же двумя эндотипами, эозинофильным или неэозинофильным. Вторичный односторонний синусит связан с одонтогенным процессом, мицетомой («грибковым шаром») или опухолью. Вторичный двусторонний синусит может быть механическим, воспалительным и иммунным; к его фенотипам относятся первичная цилиарная дискинезия, муковисцидоз, гранулематоз с полиангиитом, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом и селективный иммунодефицит.

В России кисты околоносовых пазух, как правило, классифицируют по М. И. Кадымовой:

1. ретенционные;
2. лимфоэктатические;
3. одонтогенные (радикулярные) кисты верхнечелюстной пазухи;
4. кисты, связанные с пороками развития.

Более 90% кист локализуются в верхнечелюстной пазухе, около 5% в клиновидной пазухе, в лобной пазухе и клетках решётчатого лабиринта кисты встречаются крайне редко. Более чем в 80% случаев киста односторонняя; множественные кисты выявляются лишь у четверти пациентов.

Мукоцеле чаще всего поражает лобные пазухи, реже клетки решётчатого лабиринта, верхнечелюстные и клиновидные пазухи; ряд авторов считает наиболее частой лобно-решётчатую локализацию. Описаны также крайне редкие локализации: нижняя стенка орбиты, крыловидное пространство, средняя и нижняя носовые раковины.

2.4 Клиническая картина

Клиническая картина ХРС неспецифична:

1. заложенность носа;
2. выделения из носа и стекание по задней стенке глотки;
3. головная или лицевая боль;
4. снижение или отсутствие обоняния;
5. ощущение неприятного запаха в носу;
6. у детей кашель, связанный со стеканием слизи по задней стенке глотки.

Основные симптомы, в наибольшей степени влияющие на самочувствие, это заложенность носа и выделения. Хронический синусит отличается от острого сохранением симптомов **более 12 недель** без полного их разрешения.

Кисты часто протекают бессимптомно и выявляются случайно при лучевом исследовании головы.

Крупная киста проявляется

1. чаще всего головная или лицевая боль;
2. редко внезапное истечение из носа жидкости янтарного цвета при самопроизвольном разрыве кисты;
3. онемение верхней губы или зубная боль.

Заложенность носа, выделения и кашель от стекания слизи у пациента с кистой, вероятнее всего, обусловлены сопутствующим аллергическим ринитом или ХРС.

Проявления мукоцеле зависят от локализации и размера.

Основные симптомы мукоцеле

1. головная боль;
2. ощущение давления в области лица;
3. заложенность носа;
4. выделения из носа;
5. боль в периорбитальной области.

Небольшое мукоцеле может протекать бессимптомно, однако значительно реже, чем киста.

2.5 Жалобы и анамнез

Жалобы взрослых

1. стойкая односторонняя или попеременная заложенность носа;
2. слизистые или слизисто-гнойные выделения;
3. необходимость сморкания или стекание слизи по задней стенке глотки, более выраженное после пробуждения или постоянное в течение дня;
4. неприятный запах в полости носа или носоглотке;
5. снижение обоняния вплоть до аносмии;
6. при хроническом сфеноидите периодическая боль в теменной и затылочной областях.

Для хронического фронтита характерна выраженная боль в проекции лобной пазухи на стороне поражения при обострении или при перемене атмосферного давления. Возможно ощущение давления за спинкой носа и глазными яблоками, усиливающееся при обострении.

У детей младшего возраста жалобы выясняют у родителей или опекунов:

1. частые затяжные «насморки»;
2. заложенность носа;
3. слизистые выделения;
4. кашель, преимущественно ночью или в положении лёжа на спине.

При выявлении кистоподобного образования по данным лучевых исследований в первую очередь уточняется наличие головной или лицевой боли, её постоянный характер, провоцирующие и усиливающие её факторы. Выясняются перенесённые ранее операции на полости носа и околоносовых пазухах и стоматологическое лечение.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Обязательные критерии

1. **два симптома и более**, из которых обязательно присутствуют заложенность носа (затруднение носового дыхания) или выделения из носа, передние или стекающие по задней стенке глотки;
2. сохранение симптомов **12 недель и более**.

Возможные симптомы

1. боль или ощущение распирания в проекции пазух;
2. снижение или потеря обоняния.

Подтверждение диагноза

1. эндоскопия: полипы, слизисто-гнойные выделения или отёк и обструкция слизистой оболочки, преимущественно в среднем носовом ходе;
2. компьютерная томография (КТ): изменения слизистой оболочки остиомеатального комплекса или пазух.

У детей необходимы **два и более** из четырёх симптомов на протяжении **12 недель и более**:

1. затруднение носового дыхания;
2. боль или ощущение распирания в проекции пазух;
3. выделения из носа или стекание по задней стенке глотки;
4. кашель.

Эндоскопические признаки и изменения по данным КТ такие же, как у взрослых.

Киста околоносовой пазухи: признаки на КТ или магнитно-резонансной томографии (МРТ)

1. округлое однородное мягкотканное образование на широком основании;
2. чёткие границы;
3. отсутствие деструкции кости и выраженной деформации стенок.

Отличить ретенционную кисту от лимфоэктатической можно только гистологически, по оболочке удалённой кисты.

Одонтогенная киста верхнечелюстной пазухи: признаки на КТ

1. однородное образование на широком основании на нижней стенке пазухи;
2. чёткие границы, оболочка костной плотности;
3. связь с корнями верхних зубов.

Учитывают заключение стоматолога-хирурга или челюстно-лицевого хирурга о заболевании соседних зубов.

Мукоцеле: признаки на КТ

1. образование в пазухе с округлым ровным контуром;
2. однородное содержимое без кальцинатов и включений;
3. возможны истончение прилежащих костных структур и пролабирование в соседние анатомические области.

3.2 Осмотр оториноларинголога и консультации специалистов

Всех пациентов с хроническим синуситом, с подозрением на кисту или мукоцеле осматривает оториноларинголог: собирает жалобы и анамнез, планирует лечение.

Консультация аллерголога

1. хронический синусит и отягощённый аллергологический анамнез;
2. взрослые с подозрением на кисту или мукоцеле и отягощённым аллергологическим анамнезом.

Консультация гастроэнтеролога

1. симптомы рефлюкса.

Консультация генетика

1. признаки муковисцидоза или первичной цилиарной дискинезии.

Консультация стоматолога-хирурга или челюстно-лицевого хирурга

1. подозрение на одонтогенный синусит или кисту верхнечелюстной пазухи: подтверждение или исключение одонтогенной причины.

3.3 Бактериологическое исследование

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности.

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение;
2. обострение: выбор или коррекция антибактериальной терапии.

Оптимальным материалом для исследования является аспират непосредственно из поражённой пазухи, полученный при пункции верхнечелюстной пазухи или интраоперационно.

3.4 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки

Выполняется всем пациентам с предполагаемым хроническим синуситом: оценивает синоназальные структуры и подтверждает диагноз.

Диагностические признаки

1. полипы;
2. слизисто-гнойные выделения;
3. отёк и обструкция слизистой оболочки, преимущественно в среднем носовом ходе.

3.5 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания к спиральной КТ околоносовых пазух

1. признаки осложнений при обострении;
2. подготовка к хирургическому вмешательству;
3. необходимость дифференциальной диагностики.

КТ является наиболее информативным методом как у взрослых, так и у детей.

Диагностические признаки

1. типичные признаки ХРС: утолщение слизистой оболочки и снижение пневматизации в области соустий;
2. изолированное воспаление;
3. блок соустья;
4. инородное тело;
5. диффузный грибковый процесс или мицетома;
6. опухоль;
7. аномалии развития пазух;
8. признаки одонтогенной причины.

Для планирования объёма операции используют КТ давностью **не более 6 месяцев**.

Показания

1. подозрение на кисту, выявленную другим методом и сопровождающуюся постоянными или периодическими симптомами;
2. подозрение на мукоцеле.

При затруднении дифференциальной диагностики мукоцеле с другими образованиями КТ выполняется с внутривенным болюсным контрастированием: контрастное вещество накапливается в оболочке мукоцеле, но не в его содержимом.

---

4. Лечение

Этиологических факторов ХРС много, и они могут действовать одновременно, поэтому лечение подбирают каждому пациенту индивидуально.

Основой консервативного лечения является медикаментозная терапия; по показаниям её назначают и после функциональной риносинус-хирургии.

Доказательства эффективности консервативного лечения кист и мукоцеле околоносовых пазух отсутствуют; уменьшение симптомов возможно лишь при эффективности медикаментозной терапии сопутствующего ХРС или аллергического ринита.

4.1 Базисная терапия

1. Промывание полости носа гипертоническим или изотоническим солевым раствором всем пациентам: очищает полость носа и уменьшает антигенную нагрузку на слизистую оболочку.
   Промывание полости носа имеет важное значение и в составе послеоперационного лечения.
2. Интраназальные глюкокортикостероиды (ИНГКС) пациентам **старше 12 лет** для уменьшения выраженности симптомов.
   Единая схема дозирования, кратности и длительности применения отсутствует; допустимо применение как низких, так и высоких доз. Для оценки эффекта лечение продолжается **не менее 3 месяцев**.
   Носовые кровотечения вследствие сухости слизистой оболочки чаще при высоких дозах.

   Зарегистрированное показание при ХРС есть только у мометазона, назальный спрей

   1. взрослые и дети старше 12 лет: по 2 дозы (100 мкг) в каждую половину носа 2 раза в сутки, 400 мкг в сутки.

4.2 Симптоматическая терапия при обострении

1. Сосудосуживающие капли или спреи в нос для облегчения оттока секрета из пазух, **не более 5–7 дней**.
   1. нафазолин в оториноларингологической практике не допускается: выраженное токсическое действие;
   2. предпочтительны оксиметазолин 0,01–0,05% и ксилометазолин 0,05–0,1%;
   3. строго по назначению и под контролем врача, **не более 5–7 дней**: при более длительном применении развивается медикаментозный ринит.
2. Растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием для более быстрого регресса симптомов.
   Эффективны комбинированные препараты, содержащие экстракты корня горечавки жёлтой, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины чёрной и травы вербены, а также миртол.
3. Муколитические препараты для разжижения отделяемого и облегчения его оттока.
   1. карбоцистеин коротким курсом, **до 2–3 недель**, при обострении с густым секретом в полости носа;
   2. возможны курсы около 3 месяцев в сочетании с противовоспалительными средствами;

3. одновременно с другими отхаркивающими и муколитическими средствами, в том числе местными, не назначают: усиливается стекание слизи по задней стенке глотки.

4. Нестероидные противовоспалительные препараты или парацетамол при повышении температуры тела, головной или лицевой боли.
   Детям **до 6 лет** допустимы только:
   1. парацетамол: до 60 мг/кг в сутки;
   2. ибупрофен: до 30 мг/кг в сутки.

4.3 Лёгкое обострение (0–3 балла по ВАШ)

1. Пациентам, ранее перенёсшим синусотомию, при появлении гнойных выделений: местные антибактериальные препараты.
   Эффект оценивается **через 3–4 дня**; при его отсутствии решается вопрос о системной антибактериальной терапии.

   Зарегистрированы в России для лечения ХРС
   1. фрамицетин, назальный спрей: детям с первых лет жизни; при обострении **не более 7 дней**;
   2. комбинированный спрей (дексаметазон, неомицин, полимиксин B, фенилэфрин): **с 2,5 лет**; при обострении **не более 10 дней**.

   Разовая и суточная дозы строго по инструкции.

   Введение в полость носа и околоносовые пазухи растворов антибиотиков, предназначенных для внутримышечного и внутривенного введения, не допускается: они не адаптированы для этой цели и оказывают повреждающее действие на мерцательный эпителий. Для введения в пазуху может применяться тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат.

4.4 Среднетяжёлое (4–7 баллов) и тяжёлое (8–10 баллов) обострение

1. Системная антибактериальная терапия: при среднетяжёлом и тяжёлом обострении, в том числе с периорбитальными и внутричерепными осложнениями, а также при таком обострении у пациентов с заболеваниями, повышающими риск бактериальной инфекции. Стартовый препарат в амбулаторной практике: амоксициллин с клавулановой кислотой (препараты и дозы в таблице ниже).
2. Эффект антибиотика должен проявиться **на третьи сутки**; при наличии эффекта препарат применяют **10–14 дней**.
3. Если стартовый антибиотик в амбулаторных условиях неэффективен, решают вопрос о неотложном направлении в оториноларингологическое отделение. В стационаре при среднетяжёлом течении предпочтителен приём препаратов внутрь, при его невозможности парентеральное введение; при тяжёлом, в том числе осложнённом, обострении антибиотики вводят внутривенно.
4. При неэффективности цефалоспоринов III поколения или выделении устойчивых к ним штаммов: препарат резерва (цефалоспорин IV поколения, карбапенем, оксазолидинон, гликопептид и другие) с учётом чувствительности возбудителя.
5. Детей с обострением, требующим системных антибиотиков, при невозможности назначения пенициллинов предпочтительно лечить в стационаре.
6. Пункция верхнечелюстной пазухи для дренирования: при тяжёлом обострении хронического верхнечелюстного синусита, при среднетяжёлом в случае неэффективности консервативного лечения.
   Через пункционную иглу промывают пазуху раствором антисептика, удаляют секрет и вводят антибиотик.
   Пункция допустима только при наличии результатов лучевого исследования, исключающих гипоплазию и ателектаз верхнечелюстной пазухи и подтверждающих скопление в ней секрета.
   При тяжёлом обострении пункция часто не заменяет санирующую операцию. Детям пункцию выполняют только в условиях стационара.
   Для дренирования возможны установка синус-катетера или зондирование пазух через естественные соустья.

Системные антибиотики

Препарат	Показания и режим дозирования
Амоксициллин и клавулановая кислота	Стартовый препарат при обострении в амбулаторной практике у детей и взрослых. 1. дети от 3 месяцев до 12 лет или с массой тела **менее 40 кг**, суспензии 125/31,25 мг и 250/62,5 мг в 5 мл: 40 мг/кг в сутки в 3 приёма каждые 8 часов; 2. те же дети, суспензия 400/57 мг в 5 мл: 45 мг/кг в сутки в 2 приёма; 3. высокий риск инфекции, вызванной полирезистентным пневмококком: суспензия 600/42,9 мг в 5 мл, 90 мг/кг в сутки по амоксициллину в 2 приёма; 4. дети с массой тела **более 40 кг** и пациенты **старше 12 лет**: таблетки 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	При лёгкой аллергии на пенициллины. 1. дети **младше 12 лет** или с массой тела **менее 50 кг**: 8 мг/кг в сутки в 1 приём; 2. пациенты **старше 12 лет**: 400 мг 1 раз в сутки.
Цефиксим, цефтриаксон, цефотаксим	При неэффективности амоксициллина с клавулановой кислотой. 1. пациенты **старше 12 лет** или с массой тела **от 50 кг**: цефиксим внутрь 400 мг 1 раз в сутки; цефтриаксон в/в или в/м 1–2 г 1 раз в сутки; цефотаксим в/в или в/м 1 г каждые 12 часов; 2. дети **младше 12 лет** или с массой тела **менее 50 кг**: цефиксим 8 мг/кг в сутки в 1 приём; цефтриаксон 75–80 мг/кг в сутки в 1 введение; цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 2–4 введения.
#Левофлоксацин, #моксифлоксацин	Только взрослым пациентам в амбулаторных условиях при непереносимости всех бета-лактамов или тяжёлой аллергии на пенициллины: #левофлоксацин 500 мг внутрь 1 раз в сутки или #моксифлоксацин 400 мг внутрь 1 раз в сутки, курс **10–14 дней**. Пометка off-label (в КР — знак #) обозначает применение вне инструкции.

4.5 Хирургическое лечение

Порядок хирургического лечения (экстренный, неотложный, плановый)

1. тяжёлое обострение, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями: неотложное или экстренное вмешательство;
2. среднетяжёлое обострение и неэффективность консервативного лечения: возможны малоинвазивные манипуляции в неотложном порядке;
3. остальные пациенты: плановое вмешательство по показаниям; при отсутствии показаний или наличии противопоказаний консервативное лечение и наблюдение оториноларинголога.

1. Взрослым при неэффективности **1–2 курсов** адекватной консервативной терапии: функциональная риносинус-хирургия для восстановления аэрации пазух, устранения симптомов и предотвращения осложнений.
2. Детям с хроническим синуситом и гипертрофией аденоидов III степени при неэффективности консервативного лечения **в течение 3–6 месяцев**: первым этапом удаление аденоидов.
   Вмешательство планируют при отсутствии противопоказаний, предпочтительно под общим обезболиванием в условиях оториноларингологического отделения или стационара кратковременного пребывания; при наличии соответствующего оснащения вмешательство проводится под эндоскопическим контролем.
3. Детям со среднетяжёлым и тяжёлым ХРС при неэффективности лечения **в течение 3–6 месяцев**, если гипертрофия аденоидов исключена или аденоиды удалены **более 6 месяцев** назад: функциональная эндоскопическая риносинус-хирургия.
   Операция плановая. Вмешательство не нарушает рост пазух и лицевого скелета, однако у детей выше риск рубцевания и повторного стенозирования, а малые размеры анатомических структур требуют современного оборудования.

4. Детям с изолированным поражением пазухи: эндоскопическое дренирование пазухи.

   Детям операцию выполняют независимо от состояния аденоидов, если

   1. на КТ отграниченное тотальное или субтотальное затемнение одной пазухи или резкое снижение её пневматизации;
   2. в сочетании с типичными жалобами.

   У детей необходима онкологическая настороженность в отношении любого образования на КТ, кроме кист с чёткими типичными признаками, не увеличивающихся в размерах.

5. Киста околоносовой пазухи с постоянными или периодическими симптомами: эндоскопическое удаление с опорожнением кисты и полным или частичным удалением её оболочки.
   При случайном выявлении бессимптомной кисты большинство экспертов считают хирургическое вмешательство нецелесообразным, поскольку кисты, за исключением одонтогенных, часто медленно уменьшаются самостоятельно или не изменяются.
6. Мукоцеле: эндоскопическое дренирование у всех пациентов.
   При лобной локализации методом выбора считается эндоскопическая марсупиализация с передней этмоидэктомией и фронтотомией по Драфу. При латеральном расположении мукоцеле, дефекте передней стенки лобной пазухи и большом мукоцеле с распространением в полость черепа используется наружный доступ.

> В тексте рекомендации имеется расхождение: в рекомендации о хирургическом лечении взрослых показанием является неэффективность 1–2 курсов консервативной терапии, тогда как в разделе 6 показанием к плановой госпитализации для операции названа неэффективность адекватной консервативной терапии в течение 6 месяцев.

Под функциональной риносинус-хирургией в рекомендации понимаются фронтотомия, этмоидотомия, сфеноидотомия, гайморотомия и вмешательства на структурах полости носа. У взрослых при наличии соответствующего оснащения предпочтительна эндоскопическая техника; у детей при плановом вмешательстве она обязательна.

Кисты и неосложнённые мукоцеле оперируют в плановом порядке, как правило, теми же методами функциональной риносинус-хирургии; при кистах верхнечелюстной пазухи и мукоцеле лобной пазухи в ряде случаев используются микрогайморотомия и фронтотомия через переднюю стенку.

4.6 Иное лечение

Пациенты с вторичным ХРС, у которых изменения в полости носа и околоносовых пазухах являются проявлением другого заболевания, находятся под наблюдением и получают лечение у профильного специалиста. Лечение одонтогенных кист верхнечелюстной пазухи осуществляют совместно со стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Послеоперационное ведение

После операции все пациенты находятся под амбулаторным наблюдением оториноларинголога для оценки состояния полости носа и своевременного выявления поздних осложнений.

Первый осмотр **через 7–14 дней** после выписки, далее повторно несколько раз в течение года.

Цели осмотров

1. контроль состояния полости носа: при неадекватном уходе образуются корки и синехии;
2. выявление и предупреждение осложнений;
3. выполнение манипуляций при необходимости;
4. контроль течения заболевания и своевременная коррекция лечения.

В течение месяца после операции щадящий режим; избегать факторов, повышающих давление и способных спровоцировать кровотечение:

1. интенсивных физических нагрузок;
2. перегревания;
3. переохлаждения.

Для профилактики острой респираторной инфекции избегать мест массового скопления людей, по возможности больше времени проводить дома.

5.2 Профилактика

Первичная профилактика: защита от неблагоприятных факторов внешней среды; вторичная: максимально раннее выявление заболевания.

Профилактике способствуют

1. своевременное лечение заболеваний зубов;
2. лечение гастроэзофагеального рефлюкса;
3. отказ от курения;
4. техника безопасности при работе с веществами, вредными для дыхательных путей.

Формирование мукоцеле предупреждает соблюдение принципов функциональной хирургии при операциях на полости носа и околоносовых пазухах. Риск лимфоэктатических кист снижает своевременное лечение хронического воспаления в полости носа, а радикулярных одонтогенных кист — своевременное лечение заболеваний верхних зубов.

Пациенту разъясняют

1. полное излечение затруднительно, но выраженность симптомов можно уменьшить;
2. как правило, требуется пожизненный контроль;
3. тактику лечения определяет оториноларинголог, в ряде случаев совместно с другими специалистами.

Образ жизни и лечение

1. отказ от курения или по крайней мере уменьшение количества сигарет;
2. при аллергии гипоаллергенный быт;
3. приверженность лечению и соблюдение режима дозирования;
4. правильная техника введения препаратов и промывания полости носа.

5.3 Организация медицинской помощи

Лечение ведёт прежде всего оториноларинголог, при необходимости совместно с:

1. аллергологом-иммунологом;
2. гастроэнтерологом;
3. ревматологом;
4. стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом.

Консервативное лечение и лечение лёгких обострений проводят амбулаторно.

5.4 Показания к госпитализации

Показания к экстренной госпитализации в оториноларингологическое отделение

1. внутричерепные или внутриглазничные осложнения;
2. тяжёлое обострение;
3. среднетяжёлое обострение при неэффективности амбулаторного лечения **в течение 5–7 дней**;
4. прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.

Показания к плановой госпитализации для хирургического лечения:

1. подтверждённый хронический синусит, резистентный к адекватной консервативной терапии **в течение 6 месяцев**;
2. рецидив симптомов после операции;
3. сохранение жалоб и признаков синусита у детей после удаления аденоидов;
4. изолированное воспаление с субтотальным или тотальным снижением пневматизации по данным КТ **более 2 месяцев**;
5. подозрение на новообразование пазухи неясного характера;
6. «синдром молчащего синуса» верхнечелюстной пазухи по данным КТ;
7. киста с постоянными или периодическими симптомами;
8. мукоцеле.

Пациента выписывают:

1. после выполнения операции в запланированном объёме;
2. при удовлетворительном общем состоянии;
3. при отсутствии местного или системного острого инфекционно-воспалительного процесса.

5.5 Прогноз

Эффективность лечения зависит от

1. анатомических особенностей полости носа и околоносовых пазух;
2. хронических системных заболеваний;
3. активного и пассивного курения;
4. профессиональных вредностей;
5. климатических и экологических условий;
6. приверженности пациента лечению.

Одонтогенные кисты не регрессируют самостоятельно, и их лечением совместно занимаются несколько специалистов.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический синусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025

Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	955_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки хирургического лечения у взрослых расходятся: в рекомендации о функциональной риносинус-хирургии операция показана после 1–2 неэффективных курсов консервативной терапии, в показаниях к плановой госпитализации (раздел 6) после 6 месяцев неэффективной терапии.
- Классификация по тяжести (0–3, 4–7, 8–10 баллов суммарной выраженности симптомов) ссылается на приложение Г1, в котором описана ВАШ только для оценки боли и с другой градацией.

Клинические рекомендации

Хронический средний отит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.2** — Хронический серозный средний отит **H65.3** — Хронический слизистый средний отит **H65.4** — Другие хронические негнойные средние отиты **H66.1** — Хронический туботимпанальный гнойный средний отит **H66.2** — Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит **H66.3** — Другие хронические гнойные средние отиты **H72.0** — Центральная перфорация барабанной перепонки **H90.0** — Кондуктивная потеря слуха двусторонняя **H90.1** — Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.2** — Кондуктивная потеря слуха неуточненная **H90.6** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя **H90.7** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость односторонняя, с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.8** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 29.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/698_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Основной метод лечения хронического гнойного среднего отита хирургический; каждый пациент рассматривается как потенциальный кандидат на операцию. Оперируют в период ремиссии, **не ранее чем через 3–6 месяцев** после последнего обострения.
- Всем пациентам выполняют тональную пороговую аудиометрию: она определяет степень и вид тугоухости и позволяет прогнозировать результат операции. При порогах костной проводимости **выше 30 дБ** в диапазоне разговорных частот качественного улучшения слуха не следует ожидать даже после безупречно выполненной операции.
- При подозрении на холестеатому или её рецидив показана магнитно-резонансная томография (МРТ) височных костей: в режимах Т1, Т2 и диффузионно-взвешенных изображений метод позволяет отличить холестеатому от секрета, грануляций и холестероловой гранулемы.
- В консервативном лечении основная роль принадлежит местным средствам: антисептикам, ушным каплям с противомикробными препаратами и кортикостероидами. Топические фторхинолоны не обладают ототоксичностью и допустимы при перфорации барабанной перепонки. Местное лечение эффективно только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.
- Экстренная госпитализация показана при обострении ХГСО с внечерепными или внутричерепными осложнениями; плановая — для операции в стадии вялотекущего воспаления или ремиссии **не менее 3–6 месяцев**.
- Диспансерное наблюдение:
  1. неоперированные пациенты: **раз в 6 месяцев**;
  2. после тимпанопластики или санирующей операции: **ежегодно не менее 5 лет**.

  Цель: своевременно выявить рецидив перфорации, холестеатомы и тугоухости.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) характеризуется хроническим воспалением полостей среднего уха со стойкой перфорацией барабанной перепонки, постоянным или периодическим гноетечением из уха и прогрессирующим снижением слуха на протяжении **более 3 месяцев**.

Мукозитом называется хроническое катаральное воспаление слизистой оболочки среднего уха. Тимпаносклероз является необратимым исходом неспецифического воспаления и сопровождается тугоухостью вследствие фиксации звукопроводящей цепи. Тимпанофиброз представляет собой незавершённый процесс, при котором в барабанной полости фиброзирование преобладает над воспалением. Холестеатома является белесовато-перламутровым эпидермальным образованием с оболочкой (матриксом), покрытой многослойным плоским эпителием; матрикс плотно прилежит к кости и нередко врастает в неё.

2.2 Этиология

Причины развития ХГСО у взрослых

1. хроническая патология полости носа, околоносовых пазух и носоглотки;
2. перенесённые ранее острые средние отиты;
3. системная и специфическая патология.

Инициирующее звено

1. перенесённый острый средний отит, после которого сохраняется стойкая перфорация барабанной перепонки или ретракция с атрофичной неомембраной;
2. травматическая или ятрогенная перфорация, сохраняющаяся у 1,3–10,8% пациентов после врачебных манипуляций.

Хронизации процесса способствуют анатомические особенности среднего уха и слуховой трубы, неадекватная антибактериальная терапия острого отита без дренирования среднего уха, устойчивые штаммы возбудителей, ретракция после острого отита, экссудативный средний отит, снижение местной иммунной защиты, а также заболевания носоглотки и полости носа, нарушающие мукоцилиарный клиренс слуховой трубы.

Ведущим возбудителем среди аэробов является синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), второе место по значимости занимает золотистый стафилококк. Из анаэробов чаще высеваются пептококки и пептострептококки, реже бактероиды; анаэробная флора чаще сопутствует холестеатоме. В 1,4–20% случаев выявляется грибковая флора, как правило Aspergillus и Candida.

2.3 Классификация

Формы ХГСО по МКБ-10

1. мезотимпанит (туботимпанальный отит): поражается преимущественно слизистая оболочка мезо- и гипотимпанума;
2. эпитимпанит (эпитимпано-антральный отит): процесс распространяется из эпитимпанума на клетки сосцевидного отростка и вовлекает костные структуры среднего уха.

Неперфоративные формы

1. экссудативный отит;
2. адгезивный (рубцовый) отит;
3. отит с тимпаносклерозом или тимпанофиброзом.

Перфоративные формы

1. сухой отит;
2. отит с мукозитом;
3. отит с тимпаносклерозом;
4. отит с холестеатомой.

Расположение перфорации отражает лишь преимущественную локализацию воспалительного процесса и не позволяет судить об изменениях в среднем ухе: даже при мезотимпаните разрушение цепи слуховых косточек выявляется у 10–22% пациентов, а холестеатома в барабанной полости у 11,6–42%. Поэтому для планирования операции необходима диагностика этих изменений.

Классификация Европейской академии отологии и нейроотологии и Японского отологического общества (EAONO/JOS) выделяет 4 типа холестеатомы (врождённая холестеатома, холестеатома ненатянутой части, холестеатома натянутой части барабанной перепонки и вторичная холестеатома при перфорации натянутой части) и 4 стадии: 1-я стадия соответствует поражению одного региона, 2-я стадия поражению двух и более регионов, 3-я стадия наличию внечерепного осложнения, 4-я стадия наличию внутричерепного осложнения. Регионы обозначаются по системе STAM: труднодоступные зоны (надтубарный и тимпанальный синусы), барабанная полость, аттик и сосцевидный отросток.

2.4 Клиническая картина

Пациенты предъявляют жалобы на снижение слуха и шум в ухе; при отоскопии определяется перфорация барабанной перепонки с отделяемым или холестеатомой.

Мезотимпанит: перфорация в натянутой части барабанной перепонки. Форма относительно благоприятная: признаки активной остеодеструкции отсутствуют.

Эпитимпанит: перфорация расположена в ненатянутой части барабанной перепонки. В среднем ухе развивается кариозный процесс, который может привести к лабиринтным и внутричерепным осложнениям. Разрушение кости, как правило, обусловлено холестеатомой, которая развивается из ретракционного кармана.

Эпимезотимпанит сочетает признаки обеих форм.

Частота форм ХГСО

1. мезотимпанит: 48–69% больных;
2. эпитимпанит: 15–19%;
3. эпимезотимпанит: 17–33%;

При эпитимпаните разрушение кости обусловлено холестеатомой в 79–97% случаев; холестеатома развивается из ретракционного кармана в 80% случаев.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании совокупности жалоб, данных анамнеза, физикального обследования, лабораторных и инструментальных исследований.

3.1 Жалобы и анамнез

При расспросе уточняют

Снижение слуха: на одно или оба уха.

Снижение слуха чаще двустороннее. При длительном течении заболевания с формированием тимпаносклероза, тимпанофиброза и ретракционного кармана тугоухость становится выраженной.

Выделения из уха: длительность, частота, характер.

Выделения из уха являются второй по значимости жалобой.

Около половины пациентов отмечают их 1–2 раза в год после переохлаждения, попадания воды в ухо или острого респираторного заболевания (ОРЗ). У почти трети в последние годы выделения частые или постоянные.

По характеру выделения различны: от скудных слизистых до гнойных с ихорозным запахом.

Редкие обострения на фоне выраженной тугоухости характерны для тимпаносклероза, тимпанофиброза и холестеатомы, постоянное отделяемое характерно для мукозита, гнойное отделяемое с неприятным запахом характерно для холестеатомы. Опасность эпитимпанита заключается в длительном бессимптомном течении.

Шум: в одном или обоих ушах.

Низкочастотный шум, как правило, связан с дефектом барабанной перепонки, высокочастотный шум связан с поражением внутреннего уха. При тимпаносклерозе и тимпанофиброзе шум усиливается.

Заложенность, ощущение жидкости и дискомфорт в ухе.

Подобные жалобы чаще встречаются при сохранённой натянутой части барабанной перепонки.

Эпизоды головокружения в анамнезе.

Системное головокружение или неустойчивость у больных с холестеатомой возникают при обострении, нагрузке, наклонах и поворотах головы. В половине случаев эти симптомы свидетельствуют о фистуле лабиринта. При деструкции стенки канала лицевого нерва возможен его парез.

Головная боль.

Частота жалоб

1. снижение слуха: 93–99% пациентов;
2. выделения из уха: 76–100%;
3. шум в ухе: 19–48%;
4. головокружение или неустойчивость при холестеатоме: 10–27%.

Головная боль различной локализации часто возникает при обострении. Для неосложнённого эпитимпанита боль в ухе и головная боль не характерны; их появление, как правило, свидетельствует о развитии осложнения.

3.2 Отоскопия и отоэндоскопия

Показания

1. все пациенты: отоскопия или видеоотоскопия; наряду с отоэндоскопией это определяющий метод диагностики ХГСО.

Что оценивают

1. барабанную перепонку: тонкая, утолщённая, рубцовая, очаги тимпаносклероза;
2. наличие и глубину ретракционных карманов;
3. размер и локализацию перфорации, состояние её краёв;
4. слизистую оболочку барабанной полости: мукозит, тимпаносклероз, полипы, грануляции, эпидермизация;
5. доступные осмотру слуховые косточки: кариес, лизис;
6. латеральную стенку аттика и адитус.

3.3 Степени мукозита по данным отоскопии

Степень	Изменения слизистой оболочки
I	Слизистая оболочка медиальной стенки барабанной полости утолщена, свободное отделяемое отсутствует
II	Подушкообразное утолщение слизистой оболочки медиальной стенки с большим количеством слизистых желёз, скудное слизистое отделяемое
III	Выраженная полиповидная гиперплазия слизистой оболочки мезогипотимпанума, слизистое отделяемое

При отоэндоскопии холестеатома визуализируется в 61% случаев.

Перфорация при эпитимпаните может

1. быть точечной;
2. определяться только при продувании;
3. прикрываться серной коркой;
4. временно отсутствовать в период стойкой ремиссии.

В этих случаях тщательно осматривают латеральную стенку аттика, чтобы выявить даже минимальную деструкцию.

Иногда заболевание протекает под маской рецидивирующего экссудативного отита: за прозрачным экссудатом определяется холестеатомный мешок при небольшом ретракционном кармане в ненатянутой части.

Глубокие карманы осматривают эндоскопами с углом обзора 0°, 30° и 70°.

3.4 Фистульная проба и функция слуховой трубы

Распознать фистулу лабиринта позволяет фистульная проба.

Проходимость слуховой трубы оценивают пустым глотком, пробой Тойнби, приёмом Вальсальвы или продуванием баллоном Политцера.

1. чем более выражен мукозит, тем хуже вентиляционная и дренажная функции слуховой трубы;
2. дисфункция слуховой трубы может объяснять ретракцию барабанной перепонки до операции и в отдалённом периоде и учитывается при лечении и реабилитации;
3. при нормальной функции слуховой трубы у пациента с хроническим серозным отитом следует заподозрить спонтанную отоликворею.

3.5 Осмотр полости носа и носоглотки

Необходима оценка состояния полости носа, околоносовых пазух и носоглотки: искривление перегородки носа, гипертрофический ринит, хронические заболевания околоносовых пазух и носоглотки нарушают функцию слуховых труб и снижают эффективность лечения.

3.6 Камертональные пробы

Показания

1. подозрение на снижение слуха.

Количественные (камертоны С128–2048) и качественные (С128–512) пробы Ринне, Федериче и Вебера являются скрининговым методом, позволяющим определить вид тугоухости (кондуктивная или сенсоневральная) и хуже слышащее ухо. По их результатам составляется слуховой паспорт; они же служат показанием к тональной пороговой аудиометрии.

3.7 Тональная пороговая аудиометрия

Показания

1. все пациенты с ХГСО при диагностике.

Что даёт исследование

1. степень и вид тугоухости: кондуктивная, смешанная или нейросенсорная;
2. возможности реабилитации;
3. прогноз и контроль результата операции.

При порогах костной проводимости **выше 30 дБ** в диапазоне разговорных частот качественного улучшения слуха не следует ожидать даже после идеально выполненной операции. Динамику предпочтительно оценивать на одном аудиометре у одного специалиста.

Для ХГСО характерна кондуктивная и смешанная тугоухость.

Степень зависит от

1. величины дефекта барабанной перепонки;
2. целостности и подвижности цепи слуховых косточек;
3. токсического воздействия воспалительного процесса на внутреннее ухо.

Глухота при ХГСО часто обусловлена фистулой лабиринта вследствие деструкции кости холестеатомой.

По данным аудиометрии холестеатому распознать невозможно: костно-воздушный интервал не коррелирует с характером разрушения цепи слуховых косточек, а холестеатома и грануляции сами могут проводить звук к внутреннему уху.

3.8 Рентгенография височных костей

Показания

1. ХГСО без холестеатомы: оценка сосцевидного отростка (рентгенография височных костей по Шюллеру и Майеру).

Рентгенографию применяют, только если нет подозрения на холестеатому и осложнённое течение.

3.9 Компьютерная томография височных костей

Показания

1. пациенты с ХГСО: оценка структур височных костей; метод первичной диагностики.

Что оценивают

1. распространённость процесса;
2. анатомические особенности: низкое стояние дна средней черепной ямки, высокое стояние луковицы яремной вены, предлежание сигмовидного синуса, дегисценции канала лицевого нерва и лабиринта, перегородка Кёрнера;
3. стенки барабанной полости и антромастоидального отдела;
4. цепь слуховых косточек;
5. слизистую оболочку и узкие пространства барабанной полости.

Исследование выполняют в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией; оптимальная толщина среза 0,5–0,8 мм.

КТ выявляет признаки ХГСО в 99% случаев, деструкцию стенок среднего уха в 55–97% случаев. Дифференцировать холестеатому от фиброза, грануляций, экссудата и гноя по плотности невозможно: плотность всех этих тканей составляет от +30 до +40 HU. Заподозрить холестеатому в 88% случаев позволяют локализация образования, деструкция стенок барабанной полости, слуховых косточек и антромастоидальной области, расширение входа в антрум, разрушение латеральной стенки аттика или адитуса, дефект задней стенки наружного слухового прохода, разрушение канала лицевого нерва и фистула лабиринта, чаще горизонтального полукружного канала.

При ХГСО без холестеатомы на КТ определяются изменения слизистой оболочки, рубцы вокруг цепи слуховых косточек, в ряде случаев её дефект, чаще вследствие лизиса длинной ножки наковальни. Антрум при мезотимпаните в стадии ремиссии, как правило, пневматизирован; сосцевидный отросток в большинстве случаев компактный, склеротический.

Информативность КТ при оценке оперированного уха низкая: рубцы, грануляции и пластический аутоматериал по плотности не отличаются от холестеатомы. Заподозрить холестеатому позволяет только увеличение «подозрительного» образования в динамике.

Для объективной оценки распространённости процесса КТ проводят **не ранее чем через 3–6 месяцев** после обострения. КТ в период обострения приводит к необоснованному расширению объёма операции и оправдана только при осложнённом течении.

3.10 Магнитно-резонансная томография височных костей

Показания

1. подозрение на холестеатому;
2. подозрение на рецидив холестеатомы.

1. режимы T1, T2, EPI DWI и non-EPI DWI надёжно выявляют холестеатому и её рецидив после операции: чувствительность 77–100%, специфичность 86–100%;
2. холестеатома: низкий сигнал в режиме T1, высокий или промежуточный в режимах T2 и non-EPI DWI;
3. на точность влияет размер холестеатомы;
4. для выявления рецидива МРТ имеет преимущества перед ревизионной операцией и служит ей альтернативой.

Ряд авторов для выявления холестеатомы рекомендует сочетать или совмещать КТ и МРТ: чувствительность в этом случае составляет 96%, специфичность 100%.

3.11 Вестибулометрия

Показания

1. ХГСО с холестеатомой, осложнённый фистулой лабиринта.

Исследование необходимо при системном головокружении, неустойчивости и признаках фистулы. Выявление фистулы до операции позволяет предупредить послеоперационные кохлеовестибулярные расстройства.

3.12 Общеклинические лабораторные исследования

Выполняются при подготовке к плановой операции.

3.13 Посев отделяемого из уха на бактерии

Отделяемое засевают на аэробную и факультативно-анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам.

Показан при любой форме ХГСО для подбора этиотропной терапии.

3.14 Посев отделяемого из уха на грибы

При подозрении на грибковый процесс отделяемое засевают на дрожжевые и мицелиальные грибы.

3.15 Цитологическое и патоморфологическое исследование

Исследуют ткани, удалённые из уха.

1. удалённую патологическую ткань во всех случаях направляют на патоморфологическое исследование;
2. атипичное течение: спектр исследований расширяют для исключения туберкулёза и гранулематоза Вегенера;
3. нет диагностических данных и стандартное лечение неэффективно: исследования повторяют **через 3 месяца**.

3.16 Консультации специалистов

Показания

1. сопутствующие заболевания и подозрение на осложнение: консультации невролога, нейрохирурга и терапевта.

При атипичном течении воспаления и осложнениях может также потребоваться консультация фтизиатра и ревматолога.

---

4. Лечение

Целью лечения является санация среднего уха для достижения стойкой ремиссии и предупреждения осложнений и тугоухости.

4.1 Консервативное лечение: обострение и подготовка к операции

Показания к консервативной терапии

1. обострение;
2. подготовка к операции при неосложнённом течении.

При обострении её задачей является ремиссия перед операцией; кроме того, её применяют в раннем периоде после санирующей операции.

Включает

1. бета-лактамные антибиотики;
2. анальгетики;
3. кортикостероиды;
4. процедуры, улучшающие функцию слуховой трубы.

При неосложнённом течении лечение амбулаторное, при осложнённом — стационарное.

В качестве основного метода лечения консервативная терапия носит паллиативный характер и оправдана только у пациентов с тяжёлой сопутствующей патологией при условии регулярного наблюдения.

При сухом перфоративном среднем отите проведение какого-либо лечения не рекомендуется.

> Расхождение в тексте рекомендации: в разделе 3.1 указано, что при сухом перфоративном отите лечение не проводится, тогда как в разделе 3.2 указано, что при перфорации без возможности улучшения слуха тимпанопластику следует выполнять для предупреждения рецидивов, а наилучшие результаты тимпанопластики достигаются именно при сухих перфорациях. В алгоритме (приложение Б) от сухого перфоративного отита стрелки ведут к лечению. Вероятно, запрет относится только к консервативной терапии.

Антибактериальный препарат выбирается с учётом микрофлоры, её чувствительности и способности препарата проникать через гематоэнцефалический барьер. Препаратами выбора являются бета-лактамы (пенициллины и другие бета-лактамные антибиотики), в ряде случаев респираторные фторхинолоны. Конкретные препараты и дозы в КР не приведены.

К системным препаратам прибегают, как правило, при выраженном обострении и тяжёлых распространённых деструктивных формах. Периоперационная антибиотикопрофилактика должна соответствовать характеру и объёму операции.

При смешанной микрофлоре рекомендацией предусмотрено сочетание 2–3 препаратов, например цефалоспоринов и фторхинолонов. Допускается сочетание местных противомикробных препаратов с противогрибковыми.

Основная роль принадлежит местным средствам:

1. антисептики;
2. ушные противомикробные препараты: наиболее эффективны и безопасны топические фторхинолоны (к ним чувствительны 75,6% возбудителей, они не ототоксичны и допустимы при перфорации);
3. местные противогрибковые средства;
4. кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами.

Местное лечение эффективно только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.

Грануляции в барабанной полости по возможности удаляются или прижигаются соединениями серебра; кроме того, они хорошо регрессируют под действием топических кортикостероидов.

При грибковой флоре противомикробные препараты и кортикостероиды в каплях противопоказаны. Ведение таких пациентов осуществляется строго по алгоритмам применения местных противогрибковых средств; лечение часто длительное и требует участия миколога.

> Расхождение в тексте рекомендации: абзацем выше допускается сочетание противомикробных ушных препаратов с противогрибковыми, тогда как при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны. Кроме того, «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом АТХ D01A, который относится к противогрибковым препаратам.

Дисфункцию слуховой трубы устраняют поэтапно:

1. лечение заболеваний полости носа и носоглотки, от деконгестантов и назальных кортикостероидов до хирургического вмешательства;
2. восстановление проходимости слуховой трубы продуванием по Политцеру или курсом катетеризаций с введением лекарственных препаратов;
3. восстановление активного открытия и закрытия слуховой трубы гимнастикой или электростимуляцией её мышц.

4.2 Мукозит

Кортикостероиды в каплях или в составе комбинированных препаратов используют при вялотекущем воспалении слизистой оболочки (мукозите). При неэффективности местного лечения **в течение 1–3 месяцев**, что характерно для мукозита, показано хирургическое вмешательство с дренированием.

При ХГСО с мукозитом II и III степени выполняются дренирующие операции.

Методика определяется индивидуально с учётом формы ХГСО и распространённости процесса, анатомии височной кости, степени тугоухости, состояния слуховой трубы, наличия осложнений и опыта хирурга.

1. при мукозите тимпанопластика оправдана: после восстановления функции слуховой трубы и аэрации утолщённая слизистая оболочка нормализуется;
2. слизистую оболочку удаляют инструментально или лазером;
3. выраженный мукозит: лучше оставить дренажную трубку под меатальным лоскутом или вскрыть антрум и дренировать через него барабанную полость на срок **до 2 недель**.

4.3 Хирургическое лечение: общие положения и тимпанопластика

Основной метод лечения ХГСО хирургический: только операция полностью санирует ухо и улучшает качество жизни, поэтому каждого пациента рассматривают как потенциального кандидата на операцию.

Оперируют в период ремиссии, **не ранее чем через 3–6 месяцев** после последнего обострения: объём вмешательства меньше, операция безопаснее и эффективнее.

Вынужденное вмешательство при обострении или осложнении ограничивается санацией среднего уха открытого типа, при внутричерепных осложнениях — расширенной.

Из-за кровоточивости тканей оно технически сложно и чаще сопровождается ятрогенными осложнениями.

Поэтому пациентов с осложнениями оперируют в ургентных отделениях, а вне обострения — в специализированных отделениях и центрах, владеющих реконструктивной хирургией среднего уха.

Ранняя операция на «сухом ухе» позволяет полнее санировать очаг, сохранить слух и анатомические структуры и сократить сроки реабилитации.

Для санации среднего уха и улучшения слуха выполняется тимпанопластика.

При мезотимпаните применяют тимпанопластику различных типов (4 типа по Х. Вульштейну, 5 типов по М. Тосу) и миринготомию в зависимости от степени разрушения цепи слуховых косточек.

Варианты тимпанопластики

1. протезы из хряща, наковальни, кортикальной кости, титана;
2. аутоматериалы для пластики барабанной перепонки;
3. доступ через наружный слуховой проход, эндауральный или заушный;
4. местная анестезия или наркоз;
5. под контролем эндоскопа или микроскопа;
6. в один или два этапа.

Обязательное условие успешной тимпанопластики: отсутствие выделений из уха **не менее 3–6 месяцев**.

Результат зависит от

1. срока после последнего обострения;
2. изменений в среднем ухе;
3. локализации и размера перфорации;
4. функции слуховой трубы и состояния слизистой оболочки;
5. способа реконструкции;
6. опыта хирурга и послеоперационного ведения.

Тимпанопластика эффективна в 43–98% случаев, риск глухоты на оперированное ухо составляет 1–2%. Наилучшие результаты (у 93,3% пациентов) достигаются при сухих перфорациях независимо от техники укладки трансплантата.

Второй этап тимпанопластики проводят **через 8–12 месяцев**. При перфорации без возможности улучшения слуха тимпанопластика также показана для предупреждения рецидивов ХГСО.

Мастоидотомия при тимпанопластике (или раздельная аттикоантротомия с тимпанопластикой) обоснована только при длительном вялотекущем процессе в среднем ухе.

У пациентов без холестеатомы мастоидотомия при тимпанопластике не улучшает ни анатомический результат, ни аэрацию сосцевидного отростка, но увеличивает объём и риск вмешательства. Обязательной она считается при вялотекущем хроническом перфоративном отите без холестеатомы в случае неэффективности системной и местной антибактериальной терапии.

Применение эндоскопа в дополнение к микроскопу улучшает обзор барабанной полости, однако, по данным систематического обзора, преимущества исключительно эндоскопических операций перед микроскопическими не доказаны.

При тотальных и субтотальных дефектах барабанной перепонки с изменённой слизистой оболочкой большинство хирургов для профилактики реперфорации сочетают аутофасцию, аутохрящ и кожные трансплантаты. Тонкие пластинки аутохряща препятствуют ретракции и не ухудшают акустические свойства.

Искусственные протезы и аутопротезы при оссикулопластике не различаются по слуховым результатам, однако искусственный протез без прикрытия аутохрящом смещается в 6 раз чаще.

4.4 Холестеатома

При холестеатоме эффективно местное применение препаратов борной кислоты: помимо антисептического действия, они оказывают подсушивающее действие на ткани и тем самым уменьшают воспаление.

При ХГСО с холестеатомой выполняются санирующие операции.

Основным принципом является полное удаление холестеатомы и устранение причин рецидива.

При эпитимпаните и эпимезотимпаните с холестеатомой в зависимости от распространённости процесса выбирают «открытые», «полуоткрытые» или «закрытые» санирующие операции с тимпанопластикой или без неё. С учётом объёма и длительности вмешательства операции выполняют под общей анестезией.

При холестеатоме, ограниченной аттиком или аттиком и адитусом, допустима аттикотомия через наружный слуховой проход при обязательном тщательном удалении патологического процесса из синусов и карманов среднего уха.

1. «открытая» техника (с удалением задней стенки наружного слухового прохода) избавляет от повторных операций, но не от регулярного ухода за полостью у оториноларинголога;
2. после «закрытой» операции обязательна ревизия **через 8–12 месяцев** или МРТ для исключения рецидива;
3. «закрытые» операции сопряжены с более высоким риском внутричерепных осложнений: при невозможности постоянного послеоперационного наблюдения предпочтительна «открытая» методика.

Выбор методики

1. «закрытые» методики (аттикоадитотомия, аттикоантротомия, раздельная антромастоидотомия): при ограниченной холестеатоме;
2. «открытые» методики (модифицированная радикальная, консервативно-радикальная, общеполостная операция, антромастоидотомия с удалением задней стенки, радикальная мастоидэктомия): при распространённой деструкции, активной холестеатоме или вялотекущем обострении.

Современной тенденцией является применение «полуоткрытой» (гибридной) техники: аттикоантро- или мастоидотомии с облитерацией антрума и сосцевидного отростка аутотканями или инертными материалами и тимпанопластикой. При этом анатомия уха остаётся близкой к исходной, болезнь послеоперационной полости не развивается и необходимость в пожизненном наблюдении отсутствует.

При выявлении рецидива холестеатомы после «закрытой» операции объём вмешательства расширяется до антромастоидотомии с удалением задней стенки наружного слухового прохода и формированием открытой полости.

4.5 Послеоперационное ведение

После операции наружный слуховой проход тампонируют с противомикробными препаратами:

1. после тимпанопластики **на 10–14 дней**;
2. после санирующей операции **на 14–21 день**.

Дополнительно необходимо медикаментозное и физиотерапевтическое воздействие на слуховую трубу и слизистую оболочку. В отдалённом периоде необходимо квалифицированное наблюдение.

4.6 Слухопротезирование

Электроакустическая реабилитация показана при асоциальном слухе (тугоухость **выше II степени**) и отсутствии возможности его улучшения.

Слуховые аппараты подбирают при порогах костной проводимости выше 30 дБ на оба уха, в том числе в отдалённом послеоперационном периоде.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты, которым операция противопоказана или отложена, а также отказавшиеся от неё, наблюдаются в поликлинике **раз в 6 месяцев**; при обострении применяют консервативное лечение.

После тимпанопластики и санирующих операций пациента осматривают **ежегодно не менее 5 лет** врач поликлиники и отохирург клиники, где выполнялась операция. Цель: своевременно выявить рецидив перфорации, холестеатомы и тугоухости.

Профилактика обострений

1. санация полости носа и носоглотки;
2. разъяснение пациенту характера заболевания;
3. защита уха от попадания воды, предупреждение обострений при ОРЗ;
4. своевременное обращение к врачу поликлиники и в клинику, где выполнялась операция.

После операции

1. постельный режим с положением на противоположном ухе (в зависимости от методики);
2. избегать физических нагрузок **в течение месяца**;
3. избегать авиаперелётов **в течение 3 месяцев**;
4. защищать ухо от попадания воды до завершения реабилитации.

5.1 Показания к госпитализации и выписке

Первичный осмотр пациента выполняют оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

Показания к экстренной госпитализации

1. обострение ХГСО с внечерепными или внутричерепными осложнениями.

Плановая госпитализация для операции при ХГСО, в том числе с холестеатомой, в стадии вялотекущего воспаления или ремиссии **не менее 3–6 месяцев**. Показания:

1. снижение слуха с шумом в ухе;
2. снижение слуха со скудным отделяемым, не купирующимся консервативной терапией;
3. любые клинические проявления ХГСО независимо от вида тугоухости при отсутствии общих противопоказаний и при условии обследования пациента в соответствии с требованиями стационара.

Выписка

1. после экстренной госпитализации: при отсутствии угрозы жизни и восстановлении жизнедеятельности;
2. после плановой: в зависимости от объёма операции и самочувствия, **на 3–5-е сутки** после завершения противовоспалительной и симптоматической терапии, с тампонами в наружном слуховом проходе.

После выписки амбулаторно

1. удаление тампонов **через 2–3 недели**;
2. контроль слуха по данным ТПА **через 3 и 12 месяцев**.

Эффективность лечения оценивается по жалобам на снижение слуха и выделения из уха, по данным отоэндоскопии (закрытие перфорации, отсутствие отореи, эпидермизация полости), ТПА, КТ или МРТ (санация уха, отсутствие деструкции и холестеатомы), а также по данным вестибулометрии при фистуле лабиринта.

Осложнения ХГСО

1. прогрессирующая тугоухость;
2. лабиринтит;
3. периферический парез лицевого нерва;
4. менингит;
5. абсцесс мозга;
6. тромбоз сигмовидного синуса.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический средний отит»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 29.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	698_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- При сухом перфоративном среднем отите раздел 3.1 исключает любое лечение, тогда как раздел 3.2 и алгоритм в приложении Б предусматривают при перфорации тимпанопластику.
- Сочетание противомикробных ушных препаратов с противогрибковыми допускается, однако при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны; «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом противогрибковых препаратов D01A.
- Сроки тампонады после операции различаются: в разделе 3.2 указано 10–14 дней после тимпанопластики и 14–21 день после санирующей операции, в разделе 6 указано удаление тампонов через 2–3 недели.
- Название и коды МКБ охватывают и негнойные формы (H65.2–H65.4), однако определение и весь текст рекомендации посвящены только хроническому гнойному среднему отиту.

Клинические рекомендации

Хронический тонзиллит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.2** — Хронический фарингит **J35.0** — Хронический тонзиллит **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов **J35.9** — Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/683_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз устанавливается на основании данных фарингоскопии: решающее значение имеют местные признаки хронического воспаления миндалин, наиболее важным из которых является жидкий гной в лакунах. Размер миндалин диагностического значения не имеет.
- В период острого воспаления глотки диагноз хронического тонзиллита не устанавливают: достоверная оценка его признаков возможна только **через 3–4 недели** после купирования острого процесса.
- По классификации Солдатова выделяют компенсированную и декомпенсированную формы; форму определяют по анамнезу **за последние три года**.
- Консервативное лечение назначают курсами в межрецидивный период:
  1. компенсированная форма: **2 раза в год**, весной и осенью;
  2. рецидивирующие ангины: **до 4 раз в год**, за 1–1,5 месяца до ожидаемого обострения.
- Показания к тонзиллэктомии:
  1. любой вид декомпенсации, кроме рецидивов ангин без проведённого противорецидивного лечения;
  2. рецидивирующие ангины при неэффективности противорецидивного лечения;
  3. у детей частые стрептококковые ангины: **не менее 7** за последний год, **не менее 5 в год** за последние 2 года или **не менее 3 в год** за последние 3 года.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический тонзиллит является инфекционно-аллергическим заболеванием всего организма с местными проявлениями в виде стойкого воспаления нёбных миндалин с альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

2.2 Местные признаки

Пять групп местных признаков

1. гиперемия и валикообразное утолщение краёв нёбных дужек;
2. рубцовые спайки между миндалинами и нёбными дужками;
3. разрыхлённые или, напротив, рубцово изменённые и уплотнённые миндалины;
4. казеозно-гнойные пробки или жидкий гной в лакунах;
5. увеличение регионарных лимфатических узлов.

Признаки первой группы: изменения нёбных дужек

1. признак Гизе: гиперемия краёв передних нёбных дужек;
2. признак Зака: отёк в месте соединения передних и задних дужек;
3. признак Преображенского: валикообразное утолщение краёв верхних отделов передних и задних дужек.

2.3 Классификация Солдатова

Компенсированная форма

1. местные признаки;
2. общие симптомы нерезко выражены или отсутствуют.

Декомпенсированная форма: местные признаки и хотя бы один вид декомпенсации

1. рецидивы ангин;
2. паратонзиллит или паратонзиллярный абсцесс;
3. тонзиллогенная интоксикация: длительный субфебрилитет, недомогание, снижение трудоспособности при отсутствии другой причины;
4. тонзиллогенные функциональные нарушения внутренних органов;
5. заболевания органов, патогенетически связанные с тонзиллитом.

Форму определяют по данным анамнеза **за последние три года**.

2.4 Классификация Преображенского — Пальчуна

Простая форма

1. только местные признаки;
2. в подавляющем большинстве случаев в анамнезе ангины.

Токсико-аллергическая форма I степени (признаки периодические)

1. субфебрилитет;
2. слабость, быстрая утомляемость;
3. боли в суставах;
4. увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов;
5. непостоянные функциональные нарушения со стороны сердца;
6. нестойкие отклонения лабораторных показателей.

Токсико-аллергическая форма II степени

1. функциональные нарушения сердечной деятельности, подтверждённые электрокардиографией (ЭКГ);
2. сердцебиение и нарушения ритма;
3. боли в области сердца и в суставах как во время ангины, так и вне её;
4. функциональные нарушения почек, печени, суставов и сосудов.

Сопряжённые заболевания

1. паратонзиллярный абсцесс;
2. парафарингит;
3. тонзиллогенный сепсис;
4. ревматизм;
5. артрит;
6. приобретённые пороки сердца;
7. гломерулонефрит.

Описано около 100 заболеваний, патогенетически связанных с хроническим тонзиллитом; наиболее часто поражаются сердце, суставы, почки, эндокринная система и кожа. В сложных случаях тактика ведения определяется совместно с профильным специалистом.

2.5 Жалобы и анамнез

Местные жалобы

1. незначительная боль;
2. першение;
3. ощущение инородного тела в горле;
4. периодический сухой кашель;
5. неприятный запах изо рта.

Жалобы неспецифичны: встречаются также при хроническом фарингите, заболеваниях гортани, полости рта и зубов; у части пациентов жалоб нет.

Общие жалобы при декомпенсированной форме

1. длительное недомогание;
2. снижение работоспособности;
3. затяжной субфебрилитет.

Эти жалобы неспецифичны и требуют обследования для исключения других причин.

У детей и взрослых, особенно часто и длительно болеющих, уточняются местные и общие жалобы, а также частота ангин. Многие авторы считают ангины в анамнезе наиболее достоверным признаком хронического тонзиллита, однако сведения о них должны быть подтверждены.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании:

1. анамнеза: ангины, длительная утомляемость, субфебрилитет, регионарный лимфаденит, сопряжённые с тонзиллитом заболевания;
2. физикального обследования;
3. лабораторных данных;
4. фарингоскопии.

3.1 Фарингоскопия

Показания

1. дети и взрослые: исключение острого тонзиллита и выявление местных признаков хронического тонзиллита.

При остром воспалении глотки диагноз хронического тонзиллита не устанавливают: достоверная оценка признаков возможна только **через 3–4 недели**.

Местные признаки острого тонзиллита

1. яркая гиперемия и отёк слизистой оболочки нёбных дужек, нёбных миндалин, задней стенки глотки, реже мягкого нёба и нёбного язычка;
2. экссудат и налёты на нёбных миндалинах, реже на задней стенке глотки;
3. регионарный лимфаденит: болезненность, увеличение, уплотнение поднижнечелюстных, задненижнечелюстных, передних и задних шейных лимфатических узлов;
4. петехиальная энантема на мягком нёбе и нёбном язычке.

Обследование всех пациентов включает осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал, фарингоскопию и эпифарингоскопию.

Диагностические признаки

1. решающее значение имеют фарингоскопические признаки;
2. наиболее важный признак: жидкий гной в лакунах, нередко с неприятным запахом;
3. увеличение регионарных лимфатических узлов может быть обусловлено и другими воспалительными процессами головы и шеи;
4. размер миндалин диагностического значения не имеет.

У детей гипертрофия глоточной и нёбных миндалин часто сопутствует хроническому тонзиллиту и может способствовать его развитию.

Осмотр при ярком направленном освещении двумя шпателями, при необходимости зондом.

За 20–30 минут до осмотра пациенту не рекомендуется (иначе возможна транзиторная гиперемия)

1. принимать пищу;
2. пить горячие, холодные и газированные напитки;
3. курить;
4. разговаривать на холоде.

Надавливание вторым шпателем на нёбную дужку выявляет содержимое лакун и спайки.

3.2 Анализы крови и мочи

Показания

1. выявление сопряжённых с тонзиллитом заболеваний.

Исследования

1. общий анализ крови;
2. общий анализ мочи;
3. С-реактивный белок (СРБ);
4. ревматоидный фактор.

3.3 Антистрептолизин-О

Показания

1. дифференциальная диагностика активной стрептококковой инфекции и носительства.

Высокий уровень АСЛ-О при отсутствии стрептококка в посевах свидетельствует о возможной внутриклеточной персистенции и рассматривается как подтверждение декомпенсации.

Однако высокий уровень АСЛ-О без симптомов со стороны миндалин сам по себе не является показанием к лечению и требует бактериологического исследования отделяемого из зева на стрептококк группы А или экспресс-теста.

При характерной для хронического тонзиллита внутриклеточной персистенции стрептококков культуральный метод возбудитель не выявляет. Выделение стрептококков затруднено при наличии в материале гемолитических стафилококков. Даже однократный приём системного антибиотика резко снижает вероятность выявления возбудителя культуральным методом.

Возраст	Норма АСЛ-О, МЕ/мл
До 7 лет	до 100
7–14 лет	150–200
С 14 лет	до 250

3.4 Исследование на БГСА

Показания

1. бактериологическое исследование отделяемого с нёбных миндалин на бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) или экспресс-тест.

Анализы крови и мочи, посевы и цитологическое исследование содержимого лакун для постановки диагноза практически не имеют значения. Они необходимы для уточнения формы заболевания, роли микрофлоры, связи с заболеваниями других органов и оценки эффективности лечения.

Лазерная допплеровская флоуметрия, ультразвуковое исследование (УЗИ) и другие дополнительные методы пока не получили распространения, доказательства их эффективности отсутствуют.

---

4. Лечение

Перед началом любого лечения необходимы осмотр и при необходимости санация зубов, околоносовых пазух и носоглотки.

4.1 При обострении (ангине)

Тактика при ангине определяется клиническими рекомендациями «Острый тонзиллит и фарингит», а при паратонзиллите и паратонзиллярном абсцессе рекомендациями «Паратонзиллярный абсцесс». Курсы лечения хронического тонзиллита назначают в межрецидивный период.

Взрослым при обострении рекомендованы нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для местного применения.

4.2 Системные антибиотики

Системная антибактериальная терапия при хроническом тонзиллите

1. в период обострения, при выделении стрептококка или клинических признаках тонзиллогенных осложнений: бета-лактамные препараты, прежде всего пенициллины;
2. вне обострения, при клинических признаках функциональных изменений внутренних органов, отрицательных посевах на БГСА и стойко повышенном АСЛ-О: предпочтительны современные 14-членные макролиды, курс **до 2 недель**.

Целесообразность антибактериальной терапии в межрецидивный период остаётся дискутабельной, поэтому решение принимается индивидуально на основании объективных данных, динамики симптомов и лабораторных показателей.

При подтверждённой грибковой этиологии используют противогрибковые препараты внутрь с учётом чувствительности.

4.3 Межрецидивный период: консервативное лечение

Форма	Курсы консервативного лечения
Компенсированная, простая	2 раза в год, весной и осенью
Декомпенсация в виде рецидивов ангин, токсико-аллергическая форма I степени	до 4 курсов в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемой ангины
Другие виды декомпенсации, токсико-аллергическая форма II степени	только при противопоказаниях к операции

1. Обязательное условие эффективности: дренирование лакун и очищение складок и карманов от экссудата и детрита.
2. Промывание лакун миндалин курсом **10 процедур** ежедневно или через день; не ранее чем **через 2–3 недели** после острого воспаления.
3. Антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций и таблеток для рассасывания.
4. Топические бактериальные лизаты в таблетках для рассасывания: уменьшают частоту и продолжительность обострений.
5. Растительные препараты курсами для снижения частоты ангин: корень алтея, цветки ромашки, трава тысячелистника, кора дуба, трава хвоща, корень одуванчика.
6. Консультация физиотерапевта в период ремиссии; физиотерапии предшествует курс промываний.

У детей **дошкольного и младшего школьного возраста** от промывания и смазывания миндалин следует воздержаться в связи с риском рефлекторного ларингоспазма.

Для промывания используются стерильный раствор натрия хлорида или растворы антисептиков с соблюдением дозировок и возрастных ограничений и с учётом возможной аллергии на препараты йода. Смазывание миндалин курсом 10–15 процедур выполняют отдельно или непосредственно после промывания.

4.4 Хирургическое лечение

Двусторонняя тонзиллэктомия выполняется в межрецидивный период для радикального устранения очага инфекции.

Показания к тонзиллэктомии

Основание	Показания к тонзиллэктомии
Показания по классификации Солдатова	1. любой вид декомпенсации, кроме рецидивов ангин без проведённого противорецидивного лечения; 2. рецидивы ангин: при неэффективности консервативного лечения с сохранением ангин или появлением другого вида декомпенсации.
Показания по классификации Преображенского — Пальчуна (сами формы — во вкладке «Клиника»)	1. токсико-аллергическая форма II степени; 2. простая форма и токсико-аллергическая форма I степени при неэффективности **2–3 тщательно проведённых курсов** консервативного лечения в год.

Основание	Показания к тонзиллэктомии
Показания у детей	1. частые стрептококковые ангины: **не менее 7** за последний год, **не менее 5 в год** за последние 2 года или **не менее 3 в год** за последние 3 года; 2. два и более паратонзиллярных абсцесса (в ряде случаев и после одного); 3. заключение профильных специалистов, если тонзиллэктомия необходима как этап лечения сопутствующего заболевания.
Показания по критериям Paradise	1. не менее 7 эпизодов боли в горле в предыдущем году, не менее 5 эпизодов в каждом из предыдущих двух лет или не менее 3 эпизодов в каждом из предыдущих трёх лет подряд. Эпизод: боль в горле и хотя бы один признак: температура тела 38,3 °C и выше, экссудат на миндалинах, увеличение шейных лимфатических узлов более 2 см с болезненностью, БГСА в посеве или положительный экспресс-тест. Все эпизоды должны быть задокументированы с указанием их числа и тяжести течения.

Абсолютные противопоказания

1. заболевания крови: гемофилия, лейкозы, геморрагические диатезы;
2. аномалии сосудов глотки (пульсация боковой стенки);
3. тяжёлая сердечная недостаточность II–III степени;
4. выраженная почечная недостаточность;
5. тяжёлый сахарный диабет с кетонурией;
6. тяжёлые заболевания печени;
7. тяжёлые нервно-психические заболевания;
8. злокачественные новообразования;
9. активный туберкулёз.

Относительные противопоказания

1. острые инфекционные заболевания и период 3–4 недель после них;
2. острые воспалительные заболевания и обострения хронических, в том числе ЛОР-органов;
3. эпидемии гриппа;
4. менструация;
5. неактивный туберкулёз;
6. преходящая тромбоцитопения;
7. сахарный диабет нетяжёлого течения;
8. кариозные зубы.

Наиболее частое осложнение: кровотечение из тонзиллярной ниши во время операции или **в первые 5–7 дней**, возможно и **на 8–15-е сутки**. Поэтому первые 5–7 дней пациент находится в стационаре, а после выписки ещё 5–7 дней наблюдается в поликлинике с освобождением от работы.

4.5 Послеоперационное ведение

1. в первые сутки постельный и голосовой режим; через несколько часов после операции разрешается несколько глотков воды;
2. в последующие дни щадящий режим, пища жидкая или протёртая, не горячая и не холодная;
3. местные и системные анальгетики;
4. профилактика обострения сопутствующих заболеваний.

Для обезболивания и уменьшения воспаления используют НПВП.

После тонзиллэктомии в течение **месяца** рекомендуются ограничение физической нагрузки, соблюдение режима сна и отдыха, общеукрепляющая терапия.

Пациентам с хроническим тонзиллитом необходимы соблюдение режима дня, рациональное витаминизированное питание, по показаниям диетотерапия. Естественную резистентность организма повышает периодическое курортно-климатическое лечение в санаториях, специализирующихся на патологии верхних дыхательных путей.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Компенсированная форма: курсы лечения **2 раза в год**. Если **за 3 года** не было ангин и других признаков декомпенсации, пациента снимают с диспансерного учёта.

Декомпенсация в виде рецидивов ангин: курсы лечения **3–4 раза в год**. При неэффективности лечения **в течение года**, осложнённом течении ангин или появлении другого вида декомпенсации пациента направляют на хирургическое лечение.

После тонзиллэктомии диспансерное наблюдение продолжается **6 месяцев**.

Для профилактики рецидивов и восстановления нормальной микрофлоры ротоглотки применяются биологически активные добавки (БАД), содержащие естественные бактерии ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

Риск развития хронического тонзиллита повышают несбалансированное питание (особенно дефицит витаминов A, B, E), переутомление, неудовлетворительные гигиенические условия жилья и рабочего места, загрязнённый воздух, курение, в том числе пассивное, заболевания зубов, полости носа и околоносовых пазух, частые острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и их нерациональное лечение.

Лечение, как правило, осуществляет оториноларинголог в амбулаторных условиях.

Показания к госпитализации в хирургическое отделение

1. неэффективность лечения;
2. подозрение на гнойное осложнение: паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит;
3. подозрение на новообразование;
4. необходимость хирургического лечения.

Тонзиллэктомию выполняют в оториноларингологическом отделении в плановом порядке; при неосложнённом послеоперационном периоде пациента выписывают **на 5–7-е сутки**.

Переход тонзиллита в декомпенсированную форму чаще наблюдается при иммунодефиците (врождённом, на фоне приёма иммунодепрессантов и цитостатиков, при ВИЧ-инфекции). Аутоиммунные осложнения более вероятны при стрептококковой этиологии тонзиллита и ревматической лихорадке у пациента или ближайших родственников.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический тонзиллит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	683_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Частота курсов консервативного лечения при рецидивах ангин указана по-разному: в разделе 3.1 до 4 раз в год, в разделе 5 3–4 раза в год.
- В разделе 1.4 указан код J31.1 «Хронический назофарингит», тогда как в карточке рубрикатора приведён J31.2 «Хронический фарингит». На сайте указан код из текста КР.